Banco de preguntas EUNACOM

Cuestionarios del curso (capítulos 1, 2 y 3)

1646 preguntas · 19 capítulos · 226 secciones temáticas

Cómo se armó este banco. Las preguntas provienen de los cuestionarios resueltos del curso. Se extrajo el enunciado, las cinco alternativas, la respuesta correcta y la retroalimentación del profesor tal como aparecen en el original, se eliminaron las repeticiones entre cuestionarios y se agruparon por tema. Cada pregunta indica al final el cuestionario y el número que tenía en el original; cuando una misma pregunta aparecía en más de un cuestionario, se listan todas sus apariciones.

Dos advertencias. (1) 139 preguntas de Respiratorio y Diabetes solo existían como capturas de pantalla, por lo que fueron transcritas a mano; van marcadas como "captura" en la fuente. (2) De ellas, 99 preguntas aparecían sin responder en el original: en esos casos la alternativa aparece como **Respuesta propuesta** y no proviene del curso, por lo que conviene contrastarla antes de estudiarla.

Las 46 preguntas que incluyen una imagen (electrocardiogramas, radiografías, fotografías clínicas) la llevan incrustada, extraída del cuestionario original.

Temas

Cardiología (99) **10**
Respiratorio (109) **57**
Gastroenterología (70) **91**
Nefrología (117) **121**
Endocrinología y diabetes (132) **174**
Infectología (135) **229**
Hematología (108) **282**
Reumatología (56) **328**
Neurología (96) **356**
Psiquiatría (99) **397**
Dermatología (120) **437**
Oftalmología (50) **492**
Otorrinolaringología (49) **513**
Urología (70) **535**
Cirugía (81) **564**
Traumatología y ortopedia (94) **601**
Obstetricia (60) **640**
Ginecología (41) **664**
Salud pública (60) **679**

Subtemas

Cardiología (99) **10**
Hipertensión arterial y dislipidemia (10) 10
Semiología, valvulopatías y cardiopatías congénitas (12) 14
Cardiopatía coronaria y síndrome coronario agudo (16) 19
Insuficiencia cardíaca y miocardiopatías (10) 26
Arritmias y síncope (17) 32
Electrocardiograma y trastornos electrolíticos (5) 41
Pericarditis y taponamiento cardíaco (3) 43
Endocarditis infecciosa (3) 45
Tromboembolismo pulmonar y trombosis venosa (6) 46
Patología aórtica y arterial periférica (12) 48

Paro cardiorrespiratorio y shock (5) 54
Respiratorio (109) 57
Neumonía adquirida en la comunidad (12) 57
Tuberculosis (7) 60
Asma (12) 63
Enfermedad pulmonar obstructiva crónica (14) 67
Derrame pleural y empiema (12) 71
Enfermedad pulmonar difusa y fibrosis (6) 75
Cáncer pulmonar y nódulo pulmonar solitario (7) 77
Insuficiencia respiratoria, gases arteriales y distrés (10) 79
Trauma torácico y neumotórax (7) 82
Tromboembolismo pulmonar (2) 84
Bronquiectasias (2) 84
Infecciones de la vía aérea superior (5) 85
Patología respiratoria pediátrica y neonatal (9) 86
Semiología y pruebas funcionales respiratorias (4) 89
Gastroenterología (70) 91
Esófago y reflujo gastroesofágico (6) 91
Úlcera péptica, Helicobacter pylori y cáncer gástrico (5) 93
Hemorragia digestiva (4) 95
Hepatitis agudas y crónicas (7) 97
Hepatopatías crónicas, hígado graso y autoinmunes (6) 99
Cirrosis hepática y sus complicaciones (6) 102
Lesiones focales hepáticas y hepatocarcinoma (4) 105
Vía biliar y vesícula (6) 107
Páncreas (3) 109
Enfermedad inflamatoria intestinal (3) 111
Diarrea aguda e infecciones intestinales (5) 112
Síndrome de intestino irritable y trastornos funcionales (3) 114
Malabsorción y enfermedad celíaca (5) 115
Patología colorrectal (5) 117
Isquemia mesentérica (2) 119
Nefrología (117) 121
Insuficiencia renal aguda (19) 121
Insuficiencia renal crónica y diálisis (15) 129

Síndrome nefrótico y glomerulopatías (12) 136
Síndrome nefrítico y glomerulonefritis (19) 142
Nefropatía diabética (4) 151
Trastornos hidroelectrolíticos (24) 152
Trastornos del equilibrio ácido-base (6) 162
Hipertensión arterial y causas secundarias (12) 164
Infección urinaria (6) 170
Endocrinología y diabetes (132) 174
Hipotiroidismo, hipertiroidismo, tiroiditis y bocio (27) 174
Nódulo tiroideo y cáncer de tiroides (9) 184
Patología suprarrenal (20) 188
Patología hipofisiaria (14) 197
Metabolismo del calcio y hueso (12) 203
Trastornos del sodio y del agua: SIADH y diabetes insípida (10) 207
Gónadas, amenorrea, pubertad y menopausia (11) 211
Diabetes mellitus: diagnóstico y clasificación (3) 216
Diabetes mellitus: tratamiento y control metabólico (11) 217
Complicaciones agudas de la diabetes (6) 221
Complicaciones crónicas de la diabetes (3) 224
Dislipidemias y síndrome metabólico (4) 225
Nutrición y misceláneos (2) 227
Infectología (135) 229
VIH/SIDA e infecciones oportunistas (23) 229
Tuberculosis (7) 237
Hepatitis virales (5) 240
Infecciones de transmisión sexual (7) 242
Infecciones de piel, partes blandas y micosis (15) 245
Meningitis, encefalitis y absceso cerebral (9) 251
Infecciones urinarias (8) 255
Infecciones respiratorias (11) 258
Endocarditis, bacteriemia e infecciones asociadas a catéter (6) 262
Infecciones osteoarticulares (3) 264
Diarrea infecciosa y fiebre tifoidea (9) 266
Parasitosis (7) 269
Enfermedades exantemáticas y virosis (10) 271

Zoonosis y enfermedades transmitidas por vectores (6) 275
Uso de antimicrobianos (7) 278
Prevención y aislamiento (2) 280
Hematología (108) 282
Anemias ferropénicas, microcíticas y de enfermedades crónicas (12) 282
Anemias macrocíticas y megaloblásticas (5) 287
Anemias hemolíticas (6) 289
Mielodisplasia, aplasia y pancitopenia (7) 292
Leucemias agudas (5) 295
Leucemias crónicas (8) 297
Síndromes mieloproliferativos (14) 301
Linfomas y síndrome adenopático (9) 307
Mieloma múltiple y gammapatías (6) 310
Trombocitopenias y púrpuras (11) 312
Coagulopatías y hemofilia (5) 317
Trombofilias y terapia anticoagulante (11) 320
Alteraciones reactivas del hemograma (4) 323
Oncología general (5) 325
Reumatología (56) 328
Artritis reumatoide (6) 328
Lupus eritematoso sistémico y conectivopatías (8) 331
Esclerodermia y fenómeno de Raynaud (5) 335
Miopatías inflamatorias (3) 336
Vasculitis (7) 338
Espondiloartropatías (10) 342
Artritis por cristales (4) 347
Artritis séptica y artritis en el niño (2) 349
Artrosis y reumatismo de partes blandas (5) 350
Lumbago y cervicobraquialgia (2) 353
Fibromialgia (2) 353
Osteoporosis y dolor óseo (2) 354
Neurología (96) 356
Accidente cerebrovascular (9) 356
Hemorragia subaracnoidea y traumatismo encefalocraneano (6) 359
Cefaleas y neuralgias (10) 363

Epilepsia y convulsiones (6) 367
Demencias, delirium y encefalopatías (9) 370
Trastornos del movimiento (8) 374
Enfermedades neuromusculares (12) 376
Síndromes medulares y localización de la lesión (8) 381
Pares craneales y vía visual (12) 385
Infecciones del sistema nervioso central (5) 389
Hipertensión endocraneana y tumores cerebrales (3) 391
Esclerosis múltiple (2) 392
Vértigo (2) 393
Radiculopatías y lumbociática (3) 394
Intoxicaciones (1) 395
Psiquiatría (99) 397
Trastornos del ánimo (15) 397
Trastorno bipolar (6) 403
Esquizofrenia y psicosis (6) 406
Trastorno delirante crónico (5) 408
Trastornos de ansiedad (11) 410
Trastorno obsesivo compulsivo (5) 415
Trastornos relacionados con el estrés (5) 417
Trastornos somatomorfos, conversivos y disociativos (10) 419
Trastornos de personalidad (6) 422
Psiquiatría infantil y del adolescente (5) 425
Trastornos de la conducta alimentaria (3) 427
Demencias y delirium (9) 428
Psicofarmacología y efectos adversos (5) 432
Consumo de sustancias y urgencias psiquiátricas (8) 434
Dermatología (120) 437
Dermatitis y eccemas (15) 437
Psoriasis, liquen y dermatosis papuloescamosas (13) 442
Acné y rosácea (9) 449
Infecciones bacterianas de la piel (11) 453
Micosis superficiales (7) 458
Infecciones virales e infecciones de transmisión sexual (12) 461
Parasitosis cutáneas y picaduras (7) 468

Tumores cutáneos y lesiones premalignas (16) 471
Enfermedades ampollares (4) 479
Reacciones cutáneas a fármacos (6) 480
Urticaria (3) 484
Manifestaciones cutáneas de enfermedades sistémicas (6) 485
Lesiones vasculares y dermatología neonatal (7) 487
Trastornos de la pigmentación y del pelo (4) 490
Oftalmología (50) 492
Ojo rojo: conjuntivitis, queratitis y uveítis (10) 492
Trauma ocular y urgencias oftalmológicas (9) 496
Glaucoma (7) 500
Catarata y vicios de refracción (5) 503
Retina y pérdida visual (7) 505
Neuroftalmología (9) 507
Oftalmología pediátrica (3) 510
Otorrinolaringología (49) 513
Patología del oído (9) 513
Hipoacusia y estudio auditivo (6) 517
Vértigo (4) 520
Nariz y senos paranasales (11) 521
Faringe y amígdalas (6) 525
Laringe y disfonía (6) 528
Cuello, cavidad oral y deglución (3) 530
Cuerpos extraños en vía aérea y digestiva (4) 532
Urología (70) 535
Litiasis urinaria (5) 535
Hiperplasia prostática y uropatía obstructiva (6) 538
Cáncer de próstata y antígeno prostático (8) 540
Tumores renales y de la vía urinaria (10) 543
Patología escrotal y testicular (16) 547
Infección urinaria y prostatitis (9) 554
Incontinencia urinaria y patología vesical (5) 557
Trauma urológico (4) 560
Patología del pene y prepucio (4) 561
Uretritis (3) 562

Cirugía (81) 564
Abdomen agudo y obstrucción intestinal (11) 564
Patología biliar y pancreática (9) 569
Hernias de la pared abdominal (5) 573
Patología colorrectal y anorrectal (7) 575
Trauma (6) 578
Cirugía torácica (6) 580
Cirugía vascular (9) 583
Patología cardíaca quirúrgica (7) 587
Neurocirugía (5) 590
Patología mamaria y oncología quirúrgica (5) 591
Patología tiroidea y cervical (5) 593
Complicaciones postoperatorias y profilaxis antibiótica (6) 595
Traumatología y ortopedia (94) 601
Fracturas y luxaciones del miembro superior (20) 601
Fracturas y luxaciones del miembro inferior y pelvis (10) 610
Fracturas expuestas y politraumatizado (9) 613
Complicaciones de las fracturas (13) 616
Lesiones ligamentosas, meniscales y tendíneas (7) 622
Reumatismo de partes blandas y atrapamientos nerviosos (8) 624
Ortopedia infantil (10) 628
Tumores óseos (5) 632
Infecciones osteoarticulares (6) 635
Patología de columna (6) 637
Obstetricia (60) 640
Control prenatal y diagnóstico de embarazo (12) 640
Metrorragia del primer trimestre, embarazo ectópico y molar (6) 644
Metrorragia del segundo y tercer trimestre (5) 647
Parto prematuro y rotura prematura de membranas (8) 648
Síndrome hipertensivo del embarazo (5) 651
Diabetes gestacional (3) 654
Trabajo de parto y monitorización fetal (10) 655
Puerperio y hemorragia postparto (2) 659
Infecciones durante el embarazo (5) 660
Embarazo múltiple (2) 662

Restricción del crecimiento fetal (2) 662
Ginecología (41) 664
Trastornos menstruales, amenorrea e infertilidad (6) 664
Miomas, adenomiosis y endometriosis (4) 666
Patología cervical, PAP y virus papiloma (7) 667
Hiperplasia y cáncer de endometrio (3) 670
Tumores anexiales y cáncer de ovario (4) 671
Patología mamaria (3) 672
Infecciones ginecológicas (6) 674
Anticoncepción (4) 676
Climaterio y menopausia (2) 677
Piso pélvico e incontinencia urinaria (2) 678
Salud pública (60) 679
Tipos de estudio y diseño epidemiológico (8) 679
Medidas de frecuencia (7) 682
Medidas de asociación e interpretación de resultados (8) 684
Sesgos (5) 687
Criterios de causalidad (3) 689
Tamizaje y pruebas diagnósticas (4) 690
Niveles de prevención (5) 692
Organización y financiamiento del sistema de salud chileno (11) 693
Vigilancia epidemiológica y notificación (4) 698
Responsabilidad médica y legislación (4) 699
Misceláneos (1) 701

Cardiología (99)

Hipertensión arterial y dislipidemia (10)

1. Un paciente de 58 años, diabético tipo 2, en tratamiento con metformina, presenta presiones arteriales cercanas a 146/96 en tomas repetidas. Se inicia tratamiento con dieta hiposódica, controlándose 3 meses después, con presiones promedio de 138/86 mmHg. La conducta más adecuada es:

a. Mantener indicaciones y controlar en 3 meses más
b. Iniciar enalapril y controlar ambulatoriamente
c. Iniciar hidroclorotiazida y controlar en 3 meses más
d. Iniciar amlodipino y controlar en 3 meses más
e. Iniciar atenolol y controlar en 3 meses más

Respuesta correcta: b. Iniciar enalapril y controlar ambulatoriamente

Explicación: Actualmente el objetivo de control de presión arterial en pacientes en general, es menor a 140/90, aunque para algunos autores debe ser más estricto (menor a 130/80). Sin embargo, hay relativo consenso en que en los diabéticos, nefrópatas, insuficientes renales y, según algunos, en quienes tienen un elevado riesgo cardiovascular, el objetivo debe ser menor a 130/80. Por tanto, en este caso, se debió haber iniciado directamente con tratamiento farmacológico. Además, actualmente, se recomienda comenzar directamente con dos fármacos, aunque sigue siendo perfectamente aceptable iniciar con uno solo. En este caso, por ser diabético, de elección son los IECA o ARA2 (ambos son perfectamente utilizables y la evidencia actual no privilegia a los IECA sobre los ARA2, sino que se eligen según la disponibilidad de cada uno; el losartán suele usarse una vez al día; el enalapril es un poco más barato). Si se hubiese optado por iniciar dos fármacos al mismo tiempo, sería idealmente un IECA o ARA2 más amlodipino. Las tiazidas producen resistencia a la insulina, así que se usan con cuidado en diabéticos. El betabloqueo puede ocultar los síntomas iniciales de una hipoglicemia, así que también se usan con cuidado en diabéticos.

Fuente: Cardiología, cuestionario 10.1, P1

2. Un paciente de 66 años, hipertenso, consulta por ortopnea y disnea paroxística nocturna. Al examen físico se constatan algunos crépitos bibasales y PA: 150/90 mmHg. Su electrocardiograma muestra signos de hipertrofia ventricular izquierda y su radiografía de tórax muestra una silueta cardiaca normal, con redistribución del flujo sanguíneo pulmonar hacia los ápices. El diagnóstico más probable es:

a. Miocardiopatía hipertrófica
b. Miocardiopatía dilatada
c. Cardiopatía coronaria
d. Cardiopatía hipertensiva
e. Miocardiopatía restrictiva

Respuesta correcta: d. Cardiopatía hipertensiva

Explicación: Es una cardiopatía hipertensiva clásica (antecedente de hipertensión más clínica de insuficiencia cardiaca izquierda y signos de hipertrofia ventricular izquierda: HTVI, sin cardiomegalia). La miocardiopatía hipertrófica, podría tener la misma clínica, el mismo electrocardiograma, pero en un paciente más joven sin el antecedente de hipertensión. La cardiopatía coronaria hubiese tenido antecedente de infarto o de onda Q en electrocardiograma. La miocardiopatía restrictiva tendría una clínica de instalación más rápida, y antecedente de amiloidosis, sin la hipertrofia en el electrocardiograma.

Fuente: Cardiología, cuestionario 10.1, P14 · Cardiología, cuestionario 10.5, P8

3. Un paciente de 60 años hipertenso crónico, en tratamiento con hidroclorotiazida 50 mg al día, consulta en el policlínico por control de salud. Está en buenas condiciones, sin molestias y trae anotadas sus presiones arteriales, las que promedian 150/88 mmHg. Además, tiene creatinina plasmática de 0,6 mg/dl, potasio de 3,7 mg/dl, sodio de 136 mg/dl. La conducta más adecuada es:

a. Mantener el tratamiento
b. Aumentar la dosis de la hidroclorotiazida
c. Agregar enalapril al tratamiento
d. Reemplazar la hidroclorotiazida por un IECA
e. Solicitar una ecografía doppler abdominal

Respuesta correcta: c. Agregar enalapril al tratamiento

Explicación: Es una pregunta discutible, con más de una alternativa aceptable, ya que la evidencia es contradictoria y las recomendaciones Minsal no se han adaptado a las recomendaciones internacionales, en las que tampoco hay consenso. Sin embargo, está claro que no ha logrado el objetivo de PA <140/90 mmHg (recordar que algunos proponen actualmente que el objetivo sea < 130/80 para todos y no solo para diabéticos e insuficientes renales). Por ello, se debe avanzar en el tratamiento. Si bien es aceptable reemplazar el fármaco inicial por otro, actualmente se prefiere iniciar con 2 fármacos desde el diagnóstico, por lo que agregar un segundo fármaco parece una mejor opción. Aunque no hay diferencias claras entre las distintas familias de antihipertensivos, en cuanto a su eficacia, sí la hay respecto a sus efectos adversos y otros beneficios, por lo que generalmente se iniciar con un IECA o ARA2, habitualmente más amlodipino. Sin embargo, la decisión del fármaco a elegir dependerá de la comorbilidad y preferencias del paciente. - Agregar enalapril o reeplazar la HCTZ por enalapril, ambas parecen respuestas correctas. La guía Minsal las acepta, pero está algo desactualizada. * Por regla general, la HCTZ se puede indicar entre 50 a 100 mg/día, pero lo habitual es que no se suba la dosis. Además, en este caso, el K+ está en el límite bajo, por lo que subirla podría producir una hipokalemia. - Nuestra recomendación será agregar un nuevo fármaco y solo suspender el primero, si es que está contraindicado por alguna otra razón (ejemplo, efectos adversos).

Fuente: Cardiología, cuestionario 10.2, P20

4. Un paciente diabético e hipertenso de 60 años de edad, en tratamiento con dieta y enalapril 20 mg cada 12 horas, acude a control médico, con presiones arteriales promedio 140/90 mmHg y con creatinina 0,8 mg/dl, microalbuminuria negativa, sodio: 140 mEq/l, potasio: 4,9 mEq/l, cloro: 110 mEq/L. La conducta más adecuada es:

a. Agregar hidroclorotiazida 50 mg al día
b. Reemplazar el enalapril por losartán
c. Agregar atenolol al tratamiento
d. Aumentar la dosis de enalapril a 40 mg cada 12 horas
e. Mantener el tratamiento y controlar en 3 meses

Respuesta correcta: a. Agregar hidroclorotiazida 50 mg al día

Explicación: Es un paciente HTA mal controlado, ya que el objetivo de control es menor a 130/80 en el diabético y tiene 140/90. Si hubiese tenido la microalbuminuria positiva, estaría aún más descontrolado. Por tanto se debe avanzar en el tratamiento. - Está en dosis máxima de enalapril, así que no se puede subir más y no hay razón para reemplazarlo por un ARA II, como el losartán, ya que tienen eficacias y riesgos similares (solo si el IECA produce tos o alergia: angioedema se hace necesario reemplazarlo por un

ARA II). - Por tanto, las alternativas aceptables serían 1. agregar un nuevo fármaco, en especial actualmente que se recomienda comenzar el tratamiento farmacológico con dos fármacos y 2. reemplazarlo por otro fármaco. - En este caso agregar la HCTZ parece una buena opción, en especial por el K+ en el límite superior (4,9 mEq/L), ya que las tiazidas disminuyen la potasemia. También habría sido correcto agregar amlodipino.

Fuente: Cardiología, cuestionario 10.3, P4

5. Un paciente de 60 años, hipertenso, en tratamiento con dieta hiposódica, sin otras patologías, acude a control, objetivándose que la mayoría de sus presiones arteriales son cercanas a 144/96 mmHg. La conducta más adecuada es:

a. Mantener la dieta y controlar en 3 meses
b. Iniciar captopril
c. Iniciar amlodipino
d. Iniciar nifedipino
e. Iniciar carvedilol

Respuesta correcta: c. Iniciar amlodipino

Explicación: Es un paciente con HTA en tratamiento con medidas no farmacológicas. Como no ha logrado el objetivo (menor a 140/90), se debe iniciar tratamiento farmacológico. Además, actualmente, la mayoría de recomendaciones internacionales recomiendan iniciar el tratamiento farmacológico desde el diagnóstico mismo, ya que las medidas no farmacológicas solas suelen tener menores resultados que asociadas a fármacos. No tiene ninguna comorbilidad que indique o contraindique un fármaco en específico, por lo que puede usar prácticamente cualquiera. Actualmente se recomienda iniciar con un IECA, ARA-2 o amlodipino. Las tiazidas y el betabloqueo se usan menos como monoterapia, dado su perfil de efectos adversos mayores. Además, suelen tratarse con dos fármacos desde el primer momento, siendo aceptable usar solo uno en presiones menores a 160/100, pero, probablemente mejor con 2 fármacos. De los bloqueadores de calcio dihidropiridínicos, de elección, se usa el amlodipino, porque tanto el nitrendipino como el nifedipino están obsoletos (el nifedipino se usa como tocolítico en el parto prematuro menor de 34 semanas). - Habría sido correcto también indicar enalapril, losartán, o amlodipino más enalapril o losartán.

Fuente: Cardiología, cuestionario 10.4, P1

6. ¿Qué fármaco es de elección para iniciar el tratamiento en un paciente, diagnosticado de hipertensión arterial de tipo renovascular, que no tiene daño renal ni de otros parénquimas?

a. Enalapril
b. Amlodipino
c. Hidroclorotiazida
d. Atenolol
e. Hidralazina

Respuesta correcta: a. Enalapril

Explicación: Hay dos grandes causas de HTA-RV: 1. Ateromatosis (sobre todo en mayores de 50 y con factores de riesgo cardiovascular) y 2. Displasia fibromuscular (generalmente en menores de 50 años, más frecuente en mujeres y personas con antecedentes familiares). El tratamiento de primera línea de la HTA-RV son los IECAs o los ARA-2, tanto cuando hay estenosis de una sola arteria renal como cuando la hay de de ambas. - Solo si es que los fármacos fallan, no son tolerados o producen elevación de la creatinina (lo que pasa con cierta frecuencia en la HTA RV), se debe indicar la angioplastia con un stent (la cirugía

abierta solo se usa en casos seleccionados en que anatómicamente es muy difícil de insertar un stent). Por tanto, el resumen es 1. IECA / ARA2, 2. Stent y 3. Cirugía.

Fuente: Cardiología, cuestionario 10.4, P10

7. Un paciente de 49 años, diabético tipo 2, en tratamiento con metformina y glibenclamida, presenta presiones arteriales cercanas a 138/92 en tomas repetidas, además en sus exámenes de ingreso al programa cardiovascular destaca creatinina de 0,7mg/dL y un índice microalbuminuria-creatininuria de 300. Sus exámenes previos eran similares. La conducta más adecuada es:

a. Mantener indicaciones y controlar en 1 mes
b. Iniciar enalapril y controlar en 1 mes
c. Iniciar hidroclorotiazida y controlar en 1 mes
d. Iniciar amlodipino y controlar en 1 mes
e. Iniciar atenolol y controlar en 1 mes

Respuesta correcta: b. Iniciar enalapril y controlar en 1 mes

Explicación: Es un paciente hipertenso, mal controlado, ya que la PA diastólica está en 92 mmHg y el objetivo en diabéticos es que sea menor a 130/80 mmHg. Además, por tener albuminuria, es un paciente con nefropatía diabética inicial, por lo que el objetivo de PA, en este caso, es también menor a 130/80 o incluso menor a 120-125/80. El tratamiento farmacológico de elección en los pacientes diabéticos son los IECA o los ARA2 y para rematar, por la misma albuminuria, está directamente indicado el IECA o ARA2. También sería correcto que iniciara inmediatamente con dos fármacos (ej. enalapril + diltiazem).

Fuente: Cardiología, cuestionario 10.5, P1

8. Una paciente de 40 años es diagnosticada de hipertensión arterial, mediante un perfil de presión de 3 tomas, con presiones arteriales cercanas 170/110 mmHg. En sus exámenes generales destacan una creatininemia de 1,3 mg/dl y una hipokalemia de 2,8 mEq/l. El diagnóstico más probable es:

a. Hipertensión esencial
b. Hipertensión renovascular
c. Nefropatía médica
d. Feocromocitoma
e. Hipertensión del delantal blanco

Respuesta correcta: b. Hipertensión renovascular

Explicación: Lo más probable es que sea una HTA secundaria, tanto por las PA tan elevadas, como por la edad, como por el K+ alterado, La hipokalemia orienta a HTA renovascular (RV) y a hiperaldosteronismo primario (HAP), sin embargo, la falla renal (creatininemia elevada) es más característica de la HTA RV. La edad joven orienta más a HAP que a HTA RV, aunque puede ser debido a alteraciones vasculares congénitas o a la displasia fibromuscular de la arteria renal. (Nota: la displasia fibromuscular es un conjunto heterogéneo de enfermedades que producen estenosis y dilatación de arterias medianas, de causa probablemente genética, aunque con el tabaquismo como factor de riesgo para generar complicaciones. Suele ser más frecuente en mujeres). - No es una nefropatía médica, ya que si bien cursa con elevación de la creatinina, también cursa con hiperK+ (como buena insuficiencia renal) y suele tener edema. - La HTA del delantal blanco tiene todo estrictamente normal, solo que el paciente se pone muy nervioso al tomarle la PA, lo que eleva sus cifras de PA (se estudia con Holter de PA). - El feocromocitoma se caracteriza por síntomas de tipo paroxístico de palpitaciones, angustia y crisis hipertensivas.

Fuente: Cardiología, cuestionario 10.5, P14

9. Una paciente de 45 años, dislipidémica, en tratamiento con dieta, acude a control. Presenta glicemia de ayuno de 80 mg/dl, triglicéridos de 325 mg/dl, colesterol HDL de 32 mg/dl y LDL de 90 mg/dl. La conducta más adecuada es:

a. Mantener las indicaciones
b. Iniciar una estatina
c. Iniciar un fibrato
d. Iniciar orlistat
e. Iniciar metformina

Respuesta correcta: c. Iniciar un fibrato

Explicación: Es una paciente joven, de bajo riesgo cardiovascular, por lo que el objetivo de colesterol LDL es menor a 160 mg/dl, por lo que el colesterol LDL está normal. Los TG sí están elevados (mayor a 150) y el HDL está bajo (menor a 50). Por tanto, en este caso la prioridad serán los TG, ya que a pesar de que estén bajo 500, el LDL está normal. Como ya está en tratamiento con dieta, es momento de iniciar fármacos y para los TG, la elección son los fibratos. - Eso sí, no hay evidencia clara sobre la real utilidad de los fibratos en estos casos, en que el LDL está normal y el riesgo cardiovascular es bajo.

Fuente: Cardiología, cuestionario 10.5, P15

10. Un paciente de 45 años acude a control médico, constatándose presión arterial de 150/96 mmHg. Se realiza varias tomas en días distintos, con valores siempre cercanos a los mencionados. El resto de su examen físico es normal. Se solicita fondo de ojo, electrocardiograma, hemograma, pruebas de función renal, electrolitos plasmáticos y cortisol, que resultan normales. Refiere que él lleva una vida sana, con bajo consumo de sal y actividad física regular y que su padre es hipertenso. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

a. Solicitar ecocardiograma
b. Solicitar ecografía-doppler renal
c. Iniciar enalapril
d. Iniciar hidroclorotiazida
e. Controlar en 3 meses, sin necesidad de fármacos ni exámenes

Respuesta correcta: c. Iniciar enalapril

Explicación: Tiene una hipertensión arterial aparentemente esencial, ya que no tiene ningún elemento que sugiera una causa secundaria. Actualmente se recomienda iniciar tratamiento con cambio de vida y probablemente fármacos. En su caso, que su estilo de vida ya es adecuado, corresponde agregar uno o dos fármacos. Tanto enalapril como hidroclorotiazida son opciones válidas y, de hecho, podría iniciar ambos simultáneamente, dada sus PA tan elevadas. Sin embargo, en menores de 55 años (y en diabéticos) se recomienda utilizar IECAs o ARA2 (enalapril o losartán se pueden usar casi indistintamente) como primer fármaco, por ser efectivos y con menores efectos adversos que los diuréticos.

Fuente: Cardiología, cuestionario 10.6, P9

Semiología, valvulopatías y cardiopatías congénitas (12)

11. Un paciente de 67 años consulta por disnea de esfuerzos y ortopnea, asociadas a expectoración rosada ocasional. Al examen físico se ausculta un soplo diastólico y crepitaciones bibasales. El electrocardiograma muestra una onda P ancha. El diagnóstico más probable es:

a. Estenosis mitral

b. Insuficiencia mitral
c. Estenosis aórtica
d. Insuficiencia aórtica
e. Insuficiencia tricúspidea.

Respuesta correcta: a. Estenosis mitral

Explicación: Tiene clínica clásica de estenosis mitral. Hay síntomas de insuficiencia cardiaca izquierda, (ortopnea y disnea de esfuerzo) además la hemoptisis clásica, más el soplo diastólico clásico. En electrocardiograma, muestra signos de hipertrofia de aurícula izquierda (onda P ancha).

Fuente: Cardiología, cuestionario 10.1, P2

12. Una paciente consulta por astenia y edema de EEII, que iniciaron hace cerca de 3 meses, pero que han ido en aumento. Refiere que se fatiga fácilmente y al examen se constatan yugulares visibles, con PA: 110/60 mmHg, presenta RR2T con un soplo holosistólico y presencia de onda "v" gigante en el pulso venoso. El diagnóstico más probable es:

a. Estenosis tricúspidea
b. Insuficiencia tricúspidea
c. Pericarditis constrictiva
d. Pericarditis aguda
e. Miocardiopatía dilatada

Respuesta correcta: b. Insuficiencia tricúspidea

Explicación: Tiene la clínica clásica de insuficiencia tricúspidea (clínica de insuficiencia cardiaca derecha, soplo holosistólico, más onda "v" gigante). - La estenosis tricúspidea tendría soplo diastólico y onda "a" gigante. - La pericarditis constrictiva vendría con frotes pericárdicos y colapso "y" prominente. - La pericarditis aguda viene con dolor torácico, que aumenta con la inspiración, supradesnivel del S-T difuso. - La miocardiopatía dilatada tendría insuficiencia cardiaca del lado izquierdo y signos de cardiomegalia. La miocardiopatía dilatada, también puede tener soplo holosistólico por insuficiencia mitral.

Fuente: Cardiología, cuestionario 10.1, P16

13. Paciente 80 años consulta por pérdida de conciencia mientras caminaba con recuperación completa a los pocos minutos. Relata historia de angina al esfuerzo de algunos meses de evolución. Al examen buenas condiciones, signos vitales PA 120/85, FC 78, Sat 95% ambiental. Al examen cardiaco pulsos débiles, RR2T con soplo sistólico paraesternal izquierdo irradiado a cuello, el resto del examen segmentario normal. ¿Diagnóstico más probable?

a. Miocardioapatía hipertrófica
b. Síncope vasovagal
c. Síncope ortostático
d. Estenosis aórtica
e. Síndrome conversivo

Respuesta correcta: d. Estenosis aórtica

Explicación: Tiene síncopes de esfuerzo, angina y un soplo, lo que es compatible con MCP HT obstructiva y con estenosis aórtica. Sin embargo, la edad (80 años) hace muy probable que sea una estenosis aórtica. También el pulso débil (parvus et tardus), característico de la estenosis aórtica. La MCP HT, en cambio, tiene un pulso amplio o Celler y se manifiesta en pacientes más jóvenes, al ser una enfermedad genética.

Fuente: Cardiología, cuestionario 10.2, P5

14. Un paciente de 20 años presenta síncopes, relacionados con el esfuerzo. Al examen físico, presenta un soplo sistólico eyectivo, con disminución del segundo ruido y pulso de baja amplitud, filiforme. El diagnóstico más probable es:

a. Miocardiopatía hipertrófica
b. Estenosis aórtica
c. Insuficiencia mitral
d. Insuficiencia aórtica
e. Síncope vasovagal

Respuesta correcta: b. Estenosis aórtica

Explicación: Los síncopes de esfuerzo y el soplo eyectivo son compatibles con MCP HT y con estenosis aórtica. La edad (20 años) sugiere una miocardiopatía hipertrófica, sin embargo la disminución del R2 y el pulso filiforme son compatibles con la estenosis aórtica. Por la edad, probablemente es una estenosis aórtica congénita. - La MCP HT tiene pulso amplio (Celler). El soplo de la MCP HT suele aumentar con la maniobra de Valsalva y disminuir con la posición de cuclillas, en cambio, el soplo de la estenosis aórtica hace lo contrario. - La insuficiencia mitral tiene soplo holosistólico y R1 disminuido. - La estenosis mitral tiene soplo diastólico y R1 aumentado.

Fuente: Cardiología, cuestionario 10.2, P12

15. Un paciente de 58 años presenta un cuadro de disnea de esfuerzos, asociada a ortopnea, progresivas, de algunos meses de evolución. Al examen físico se constata un soplo cardíaco sistólico, asociado a desplazamiento del choque de la punta. ¿Qué diagnóstico es más compatible?

a. Insuficiencia mitral
b. Estenosis aórtica
c. Micardiopatía hipertrófica
d. Pericarditis constrictiva
e. Insuficiencia aórtica

Respuesta correcta: a. Insuficiencia mitral

Explicación: La clínica muestra síntomas de ICC izquierda (disnea, ortopnea), más soplo sistólico (holosistólico) y signos de cardiomegalia. La insuficiencia mitral tiene todo eso y se caracteriza por un soplo sistólico. La estenosis aórtica y la MCP HT sí tienen la ICC izquierda y el soplo sistólico (mesosistólico), pero no tienen cardiomegalia, sino una HT concéntrica. La insuficiencia aórtica tiene ICC izquierda y cardiomegalia, pero su soplo es diastólico.

Fuente: Cardiología, cuestionario 10.2, P14

16. Un paciente de 60 años consulta por astenia y edema de extremidades inferiores. Al examen físico se aprecia una onda "a" aumentada en el pulso venoso y se ausculta un soplo diastólico. El diagnóstico más probable es:

a. Estenosis pulmonar
b. Insuficiencia pulmonar
c. Estenosis tricuspidea
d. Insuficiencia tricuspidea
e. Pericarditis constrictiva

Respuesta correcta: c. Estenosis tricuspidea

Explicación: Es una insuficiencia tricuspidea clásica (signos de ICC derecha: edema y astenia; soplo diastólico y onda "a" gigante). Las demás opciones también tienen clínica de ICC derecha, pero la estenosis pulmonar tiene soplo sistólico; la insuficiencia pulmonar tiene soplo diastólico, sin afectación del pulso venoso y la insuficiencia tricuspidea tiene soplo holosistólico, con onda "v" gigante. La pericarditis constrictiva tiene frotes pericárdicos, signo de Kussmaul y colapso "y" prominente.

Fuente: Cardiología, cuestionario 10.3, P10

17. Un paciente de 80 años presenta un síncope mientras caminaba. Al examen físico se ausculta un soplo sistólico eyectivo, con disminución del R2. ¿Qué diagnóstico es el más probable?

a. Estenosis mitral
b. Insuficiencia mitral
c. Estenosis aórtica
d. Insuficiencia aórtica
e. Bloqueo AV

Respuesta correcta: c. Estenosis aórtica

Explicación: Es una estenosis aórtica clásica: síncopes de esfuerzo, soplo eyectivo o mesosistólico y disminución del R2. La estenosis mitral tiene soplo diastólico y aumento del R1. La insuficiencia mitral tiene soplo holosistólico y disminución del R1. La insuficiencia aórtica tiene soplo diastólico y disminución del R2. El BAV completo tiene bradicardia y R1 de intensidad variable.

Fuente: Cardiología, cuestionario 10.4, P5

18. Un paciente de 30 años consulta por disnea de esfuerzo y angina de pecho. En su examen físico se constata un pulso amplio y un soplo sistólico eyectivo. ¿Qué examen es el más adecuado para confirmar la sospecha diagnóstica?

a. Ecocardiografía
b. Holter de arritmias
c. Coronariografía
d. Test de esfuerzo
e. Radiografía de tórax

Respuesta correcta: a. Ecocardiografía

Explicación: La sospecha es una miocardiopatía hipertrófica. La disnea (ICC), la angina y el soplo también se ven en la estenosis aórtica, pero el pulso amplio es de MCP HT (también de la insuficiencia aórtica), en cambio, la estenosis aórtica tiene un pulso pequeño y lento (parvus et tardus). De todos modos, cualquiera que haya sido sus sospecha, igual se debe pedir una ecocardiografía, así que es una pregunta fácil.

Fuente: Cardiología, cuestionario 10.4, P17

19. Un paciente de 67 años consulta por astenia y edema de extremidades inferiores, no asociado a otros síntomas. Al examen físico se ausculta un soplo diastólico y ondas "a" gigantes en el pulso venoso. El diagnóstico más probable es:

a. Estenosis mitral
b. Insuficiencia mitral
c. Estenosis tricuspidea
d. Insuficiencia aórtica

e. Insuficiencia tricuspidea

Respuesta correcta: c. Estenosis tricuspidea

Explicación: Es una estenosis tricúspidea clásica: clínica de ICC derecha (edema), con soplo diastólico, más las onda "a" gigantes en el pulso venoso. La estenosis mitral tiene clínica de ICC izquierda, más el soplo diastólico. La insuficiencia mitral tiene ICC izquierda, más soplo holosistólico. La insuficiencia aórtica tiene ICC izquierda, más soplo diastólico. La insuficiencia tricúspidea tiene ICC derecha, más soplo holosistólico y onda "v" gigante en el pulso venoso.

Fuente: Cardiología, cuestionario 10.5, P2

20. Un recién nacido de 30 días de vida, ha tenido un mal incremento ponderal y pareciera fatigarse al mamar. Al examen físico tiene crépitos pulmonares y se ausculta un soplo continuo. El diagnóstico más probable es:

a. Tetralogía de Fallot
b. Coartación aórtica
c. Comunicación interauricular
d. Comunicación interventricular
e. Ductus arterioso persistente

Respuesta correcta: e. Ductus arterioso persistente

Explicación: Es un DAP clásico: con el soplo continuo (también llamado sistodiastólico o en maquinaria). La tetralogía de Fallot tiene cianosis que no responde a O2 al 100%. La coartación aórtica tiene disminución de los pulsos pedios, más un soplo eyectivo. La CIA tiene un soplo eyectivo, más desdoblamiento del segundo ruido. La CIV tiene un soplo holosistólico. Nota: CIA y CIV pequeños pueden ser asintomáticos y/o tener una auscultación cardíaca normal.

Fuente: Cardiología, cuestionario 10.5, P20

21. La asociación de disnea de esfuerzo, ortopnea, disnea paroxística nocturna, cardiomegalia, soplo diastólico y danza arterial es característica de:

a. Estenosis aórtica
b. Insuficiencia aórtica
c. Miocardiopatía dilatada
d. Insuficiencia mitral
e. Estenosis mitral

Respuesta correcta: b. Insuficiencia aórtica

Explicación: Es una insuficiencia aórtica clásica (ver resumen de semiología cardíaca).

Fuente: Cardiología, cuestionario 10.6, P1

22. Una paciente de 27 años, cursando un embarazo de 20 semanas, es derivada por sospecha de asma, ya que ha presentado disnea relacionada con el ejercicio y escasa tos. Al interrogatorio, refiere síntomas intermitentes de 4 o 5 años de evolución, pero que han empeorado mucho en el último mes. Al examen físico tiene signos vitales normales, pero satura 92% a FiO2 ambiental. Su examen pulmonar es normal y su examen cardíaco solo tiene un soplo sistólico II/VI. Su electrocardiograma muestra eje desviado a derecha y signos de hipertrofia de la aurícula y ventrículo derecho. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

a. Solicitar test de esfuerzo
b. Solicitar espirometría

c. Solicitar angioTAC de tórax
d. Solicitar ecocardiografía de manera urgente
e. Iniciar budesonida cada 12/horas más salbutamol en caso de síntomas, por vía inhalada

Respuesta correcta: d. Solicitar ecocardiografía de manera urgente

Explicación: Respuesta incorrecta. Tiene una sospecha de cardiopatía congénita del adulto en el embarazo, lo que es una urgencia, por alto riesgo materno y fetal. Por la clínica, la sospecha es una comunicación interauricular. Se diagnostica con ecocardiografía y su tratamiento dependerá de la gravedad. Por ser adulta, es posible que haya desarrollado hipertensión pulmonar secundaria o bien que se trate de un defecto pequeño sin complicaciones. Por estar embarazada, debe estudiarse de inmediato.

Fuente: Cardiología, cuestionario 10.6, P13

Cardiopatía coronaria y síndrome coronario agudo (16)

23. Un paciente de 45 años consulta por dolor torácico opresivo intenso, irradiado al brazo izquierdo. Al examen físico está en buenas condiciones, con MP+ sin ruidos agregados y RR2T sin soplos. Se solicita una radiografía de tórax que es normal, al igual que el ECG. Se administra oxígeno y aspirina y se controlan troponinas plasmáticas y electrocardiogramas seriados, que permanecen negativas. Al tercer día está en buenas condiciones, ya sin dolor ni alteraciones en el examen físico. ¿Qué examen sería recomendable realizar en este momento?

a. Test de esfuerzo
b. Ecocardiografía
c. Coronariografía
d. Mioglobina
e. Holter de arritmias

Respuesta correcta: a. Test de esfuerzo

Explicación: Tiene un cuadro clínico de dolor torácico, sugerente de síndrome coronario agudo. Como el electrocardiograma está normal, es sin supradesnivel del ST. Como el paciente evolucionó bien, antes de darlo de alta se debe hacer un test de esfuerzo. Si el test de esfuerzo estuviese alterado, hay que hacerle angioplastia igual. En este caso, se manejó como un síndrome coronario agudo, sin supradesnivel del ST, de bajo riesgo, ya que no se hizo angioplastia. La coronariografía hubiese sido la respuesta correcta en agudo, con un cuadro clínico y signos de alto riesgo ejemplo edema pulmonar agudo. La ecocardiografía si es correcto pedirla, pero en este caso preguntan el manejo pre-alta y por eso es el test de esfuerzo.

Fuente: Cardiología, cuestionario 10.1, P3

24. Un paciente de 60 años consulta por dolor torácico, irradiado al cuello, que inició hace 1 hora y que se asocia a disnea. Al examen físico presenta un RR3T, por presencia de un cuarto ruido, con PA: 140/90 mmHg y FC: 90x'. Se solicita un electrocardiograma que muestra un supradesnivel del ST en DI, V5 y V6. La conducta más adecuada es:

a. Iniciar aspirina, oxígeno y nitroglicerina y realizar trombólisis de urgencia
b. Iniciar aspirina, oxígeno y nitroglicerina y solicitar un test de esfuerzo de urgencia
c. Iniciar aspirina, oxígeno y nitroglicerina y solicitar un angioTAC de tórax
d. Iniciar aspirina, oxígeno y nitroglicerina y solicitar un ecocardiograma de esfuerzo
e. Administrar analgésicos y solicitar coronariografía diferida.

Respuesta correcta: a. Iniciar aspirina, oxígeno y nitroglicerina y realizar trombólisis de urgencia

Explicación: Es un síndrome coronario agudo (dolor torácico, R4) con supradesnivel del ST, de la pared lateral (D1, V5 y V6). Lo más correcto es el manejo general (aspirina, O2, nitroglicerina y ya no se da la morfina salvo casos muy seleccionados) más revascularizar de inmediato, con angioplastia o con trombólisis. - En este caso con menos de 3 horas de dolor, la trombólisis suele tener buen resultado, aunque la angioplastia inmediata sigue siendo el manejo ideal. Por tanto, si hubiese estado disponible la angioplastia, a menos de 90 minutos de distancia, hubiese sido más correcto hacer la angioplastia.

Fuente: Cardiología, cuestionario 10.1, P9

25. Un paciente cursando el 4to día postinfarto miocárdico, presenta rápido deterioro del estado hemodinámico y respiratorio y al examen físico se ausculta un soplo holosistólico, que antes no tenía, asociado a frémito. El diagnóstico más probable es:

a. Disección aórtica
b. Rotura de la pared libre ventricular
c. Rotura del tabique interventricular
d. Pseudoaneurima ventricular
e. Infarto de ventrículo derecho

Respuesta correcta: c. Rotura del tabique interventricular

Explicación: Que esté entre el día 2 y 7 desde el infarto, lo que sugiere una complicación mecánica. Además, el soplo holosistólico sugiere rotura de tabique interventricular (produce CIV aguda) o rotura de músculo papilar (produce insuficiencia mitral aguda, que no está en las alternativas). Se debe solicitar un ecocardiografía urgente (tanto transtorácico como transesofágico sirven) y se manejan con cirugía urgente. - La disección aórtica sería concomitante con el dolor y tendría un soplo diastólico de insuficiencia aórtica. - La rotura de pared libre ventricular tendría clínica de taponamiento. - El pseudoaneurisma ventricular tendría un supradesnivel del ST persistente y fenómenos embólicos. - El infarto de ventrículo derecho sería concomitante con el dolor torácico, con hipotensión arterial e ingurgitación yugular.

Fuente: Cardiología, cuestionario 10.1, P17

26. Paciente que acude a control ambulatorio con antecedentes de infarto al miocardio anteroseptal con reperfusión adecuada hace dos semanas, actualmente, asintomático cardiovascular. Se controla ECG que destaca supradesnivel en pared anterior. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

a. Aneurisma ventricular
b. Insuficiencia mitral isquémica
c. Isquemia persistente
d. Necrosis transmural
e. Pericarditis postinfarto

Respuesta correcta: a. Aneurisma ventricular

Explicación: El SDST persistente es una forma característica de presentación del aneurisma ventricular (aunque no es tan específico), que, además, produce embolias a repetición y tiene riesgo de rotura, con taponamiento y muerte súbita. Como todas las complicaciones mecánicas del IAM, se debe estudiar con ecocardiografía y luego debe resolverse quirúrgicamente. La forma más habitual en que se diagnostican es con la ecocardiografía que todo paciente con infarto debe realizarse posteriormente, tanto para ver el grado de daño estructural, como la función ventricular (elemento pronóstico más importante). Si hubiese estado además con dolor torácico, probablemente sería un nuevo IAM transmural. La necrosis transmural

se ve inicialmente como un SDST y luego como una onda Q (esta última persiste por toda la vida... si sobrevive).

Fuente: Cardiología, cuestionario 10.2, P7

27. Un paciente de 66 años, diabético e hipiertenso, presenta un síndrome coronario agudo hace 3 días, que fue trombolizado 5 horas después de haber iniciado los síntomas, con mejoría sustancial. Estando hospitalizado en la unidad coronaria, presenta disnea de rápida instalación, asociado a hipotensión y signos de shock. Al examen físico llama la atención la presencia de un soplo pansistólico, que no se había registrado previamente. El diagnóstico más probable es:

a. Disección aórtica
b. Rotura de la pared libre ventricular
c. Rotura del músculo papilar
d. Tromboembolismo pulmonar
e. Infarto de ventrículo derecho

Respuesta correcta: c. Rotura del músculo papilar

Explicación: Que esté entre el día 2 y 7 desde el infarto, lo que sugiere una complicación mecánica. Además, el soplo holosistólico sugiere rotura de tabique interventricular (produce CIV aguda) o rotura de músculo papilar (produce insuficiencia mitral aguda, que no está en las alternativas). La disección aórtica sería concomitante con el dolor y tendría un soplo diastólico de insuficiencia aórtica. La rotura de pared libre ventricular tendría clínica de taponamiento. El pseudoaneurisma ventricular tendría un supradesnivel del ST persistente y fenómenos embólicos. El infarto de ventrículo derecho sería concomitante con el dolor torácico, con hipotensión arterial e ingurgitación yugular.

Fuente: Cardiología, cuestionario 10.2, P9

28. Un paciente de 62 años, con antecedente de diabetes en tratamiento con metformina y glibenclamida, consulta por sensación de opresión precordial y leve dolor, desde hace 3 meses, síntomas que aparecen cuando realiza esfuerzos moderados, como caminar un par de cuadras o subir dos pisos de un edificio por las escaleras. El dolor se irradia al hombro izquierdo, cede con el reposo, durando cerca de 3 minutos y no se ha asociado a otros síntomas. Se solicita un electrocardiograma, que muestra un trazado normal. La conducta más adecuada es:

a. Solicitar un ecocardiograma
b. Solicitar un test de esfuerzo
c. Solicitar troponinas plasmáticas
d. Solicitar angioTAC de tórax
e. Indicar aspirina, nitroglicerina y acenocumarol, e iniciar un programa de ejercicios

Respuesta correcta: b. Solicitar un test de esfuerzo

Explicación: Tiene una angina estable, cuyo diagnóstico es clínico. Sin embargo, suelen estudiarse con un test de esfuerzo, ya sea para confirmar los casos dudosos o, especialmente, para determinar el pronóstico y manejo. Dentro de los test de esfuerzos, está el convencional, es decir, el electrocardiograma con ejercicio. Este es el examen ideal, ya que es el que entrega mayor información. Sin embargo, en algunos pacientes no se puede realizar (ej. BCRI, que inutiliza el EKG; amputados; personas que no toleran el ejercicio). En estos casos, se realiza una imagen de estrés, ya sea una ecocardiografía dobutamina (u otro fármaco que aumente la frecuencia cardíaca) o una cintigrafía miocárdica de esfuerzo (ej. con talio más dipiridamol). - El tratamiento suele ser la revascularización, con stent o by-pass coronario. La decisión de usar uno u otro depende de la coronariografía (examen que se pide en todo paciente con angina crónica

de riesgo: ej. test de esfuerzo alterado). - También sirven algunos fármacos tanto para aliviar el dolor (nitritos de corta acción, como la nitroglicerina sublingual), como para prevenir los síntomas (principalmente betabloqueo, siendo también útiles los nitritos de larga acción como el isosorbide dinitrato y los bloqueadores del calcio no dihidropiridínico como el verapamilo y el diltiazem). El betabloqueo está contraindicado en la angina vasoespástica o de Prinzmetal. - Sin embargo, de los fármacos, el más importante es la aspirina para prevenir síndromes coronarios agudos. También sirven las estatinas y medicamentos para sus patologías de base, que causan la enfermedad coronaria. * Si hubiese dicho que además tenía síncopes o soplo sistólico, lo más correcto hubiese sido la ecocardiografía, ya que se sospecharía una estenosis aórtica o una MCP HT. * Si hubiese sido una angina inestable (ej. Primer episodio o dolor de reposo), la respuesta hubiese sido el EKG y las troponinas, por tratarse de un síndrome coronario agudo.

Fuente: Cardiología, cuestionario 10.2, P11

29. Un paciente de 69 años, cursando un infarto miocárdico, de 40 minutos de duración, presenta deterioro de su estado general, constatándose frecuencia cardíaca de 40 x'. La conducta inicial es: a)

a. Administrar atropina endovenosa
b. Administrar propanolol endovenoso
c. Administrar adrenalina endovenosa
d. Administrar amiodarona endovenosa
e. Realizar cardioversión eléctrica endovenoso

Respuesta correcta: a. Administrar atropina endovenosa

Explicación: Es un IAM complicado con bradicardia. Las causas más frecuentes son las reacciones vagales, que se pueden controlar con atropina endovenosa y la isquemia del sistema excitoconductor, que se maneja con marcapasos externo transitorio y eventualmente un marcapasos definitivo. Si no hay mayor información, la primera medida suele ser la atropina, para descartar la reacción vagal.

Fuente: Cardiología, cuestionario 10.3, P3

30. Un paciente de 68 años acude al servicio de urgencia por dolor torácico opresivo, irradiado a los brazos. Es diabético y dislipidémico y toma aspirina, atorvastatina y metformina. Al examen físico está hipotenso (PA: 90/50), taquicárdico, sudoroso, con MP+ sin ruidos agregados y RR3T con presencia de un cuarto ruido. Se solicita un electrocardiograma que muestra un supradesnivel del segmento ST en las derivaciones DII, DIII y AVF. La conducta más adecuada es:

a. Iniciar aspirina, oxígeno y realizar angioplastia de urgencia
b. Iniciar aspirina, nitroglicerina, morfina y realizar trombólisis con estreptoquinasa
c. Iniciar aspirina, oxígeno y solicitar troponinas seriadas
d. Iniciar aspirina y solicitar test de esfuerzo
e. Solicitar ecocardiograma transesofágico de urgencia

Respuesta correcta: a. Iniciar aspirina, oxígeno y realizar angioplastia de urgencia

Explicación: Tiene un síndrome coronario agudo con SDST (de la pared inferior: DII, DIII y AVF), que se puede manejar con angioplastia o trombólisis. Lo ideal es la angioplastia, ya que tiene mejores resultados que la trombólisis. Además, en este caso el paciente está hipotenso (PA: 90/50), lo que contraindica la trombólisis (porque puede agravar la hipotensión), por lo tanto, no hay duda de que la respuesta correcta es la angioplastia. En este caso, por la hipotensión, también está contraindicada la nitroglicerina y también la morfina (aunque actualmente no se recomienda la morfina, salvo casos muy específicos).

Fuente: Cardiología, cuestionario 10.3, P7

31. Un paciente con antecedente de angina estable, a la espera de cirugía de revascularización, consulta por dolor torácico que inició en el reposo y que es un poco más intenso que el dolor habitual. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

a. Solicitar electrocardiograma y realizar manejo como un síndrome coronario agudo
b. Administrar nitroglicerina y solicitar test de esfuerzo
c. Administrar aspirina y nitroglicerina y solicitar ecocardiograma con dobutamina
d. Administrar nitroglicerina e iniciar trombolisis con estreptoquinasa
e. Iniciar bomba de nitroprusiato y solicitar angioTAC de tórax

Respuesta correcta: a. Solicitar electrocardiograma y realizar manejo como un síndrome coronario agudo

Explicación: Tiene una angina inestable, tanto por el dolor de reposo, como por la duración distinta (angina que cambia). El manejo de la angina estable es el manejo del síndrome coronario agudo, porque es un síndrome coronario agudo. Las anginas inestables (en contraposición con la angina estable) son: - Dolor de reposo. - Dolor diferente al habitual (mayor intensidad o duración). - Primer episodio de angina con el ejercicio. Todas se manejan como SCA.

Fuente: Cardiología, cuestionario 10.4, P3

32. Un paciente de 65 años, cursando un IAM de pared inferior de 3 horas de evolución, presenta deterioro del estado circulatorio y se objetiva que presenta una frecuencia cardíaca de 30 lpm. La primera medida a realizar es:

a. Administrar adenosina
b. Administrar lidocaína
c. Administrar un digitálico
d. Administrar atropina
e. Administrar adrenalina

Respuesta correcta: d. Administrar atropina

Explicación: La primera medida en un paciente con bradicardia, cursando un infarto, es administrar atropina. Si no responde, o si la clínica no orienta a una descarga vagal, se debe instalar un marcapasos transitorio. Lo mismo aplica a otras causas de bloqueo aurículo-ventricular con hemodinamia inestable: primero atropina y si no responde, marcapasos externo transitorio. La decisión de dejar un marcapasos definitivo depende de si la causa de la bradicardia es identificada y tratada (en este caso, la isquemia puede ser reversible y evitarse el uso de marcapasos definitivo). Si la causa es irreversible (ej. degenerativa), se indica marcapasos definitivo en el BAV de tercer grado, en el de segundo grado Mobitz II y en el trifasicular. El de segundo grado Mobitz I y la enfermedad del nodo sinusal rara vez lo requieren, estando indicado solo si son sintomáticos (ej. síncopes por bradicardia).

Fuente: Cardiología, cuestionario 10.4, P7 · Cardiología, cuestionario 10.6, P12

33. Un paciente de 70 años presenta un cuadro de dolor torácico intenso, que luego se acompaña de hipotensión arterial. Al examen físico se aprecian yugulares ingurgitadas. Se solicita un electrocardiograma que muestra supradesnivel del segmento ST en las derivadas AVF, DII y DIII y se solicitan derivadas derechas que muestran supradesnivel del segmento ST en las precordiales derechas V3R, V4R y V5R. La conducta más adecuada es:

a. Realizar pericardiocentesis de inmediato
b. Iniciar oxígeno, nitroglicerina, morfina y aspirina y realizar trombolisis de urgencia

c. Iniciar oxígeno, nitroglicerina, morfina y aspirina y realizar angioplastia de urgencia

d. Administrar suero fisiológico, iniciar oxígeno, aspirina y realizar angioplastia de urgencia

e. Solicitar AngioTAC de tórax de urgencia

Respuesta correcta: d. Administrar suero fisiológico, iniciar oxígeno, aspirina y realizar angioplastia de urgencia

Explicación: Tiene un infarto de ventrículo derecho, tanto por la clínica (hipotensión e ingurgitación yugular, en articular asociado a IAM de pared inferior: SDST en DII, DIII y AVF). La forma en que se diagnostica es con las precordiales derechas, que suele mostrar SDST en V4R, así que ya está confirmado (cuando queda la duda, se puede hacer un ecocardiograma de urgencia, que muestra la disfunción del ventrículo derecho). - El tratamiento es principalmente el del manejo general del infarto, pero está prohibido dar cualquier fármaco que hipotense (como la nitroglicerina, la morfina o la trombólisis), por lo que no pueden ser la B ni la C. Además, se debe administrar suero fisiológico. En caso de que siga hipotenso y no responda al volumen, se puede agregar dopamina u otras drogas vasoactivas. * La pericardiocentesis hubiese sido correcta en la rotura de pared libre, que cursa con taponamiento y tiene la misma clínica, pero habitualmente algunos días después del IAM, ya que es una complicación mecánica.

Fuente: Cardiología, cuestionario 10.4, P11

34. En un paciente cursando un infarto agudo al miocardio, ¿qué hallazgo electrocardiográfico es indicación de trombólisis?

a. Infradesnivel del ST

b. Imagen de bloqueo completo de rama izquierda

c. Imagen de bloqueo completo de rama derecha

d. Inversión de la onda T

e. Presencia de fibrilación auricular

Respuesta correcta: b. Imagen de bloqueo completo de rama izquierda

Explicación: La trombólisis solo se indica en el síndrome coronario agudo con SDST, y solo si es que no hay disponibilidad de angioplastia. El BCRI agudo, es equivalente a un SDST. Es importante recordar que el SCA sin SDST es una contraindicación de la trombólisis y, por tanto, debe ser manejado con otras medidas (ej. angioplastia o solo medidas farmacológicas conservadoras, según el riesgo), pero nunca con trombólisis.

Fuente: Cardiología, cuestionario 10.4, P20

35. Paciente 58 años, tabáquico, hipertenso, dislipidémico, con historia de angina estable en tratamiento irregular con aspirina, enalapril y atorvastatina. Se realiza un test de esfuerzo que resulta positivo. ¿Cuál de las siguientes sería la conducta más adecuada?

a. Realizar ecocardiografía

b. Realizar coronariografía

c. Agregar propanolol al tratamiento habitual

d. Realizar cintigrafía talio-dipiridamol

e. Realizar trombolisis endovenosa

Respuesta correcta: b. Realizar coronariografía

Explicación: El estudio de la angina estable es con un test de esfuerzo, o un equivalente (ecocardiografía de esfuerzo o cintigrafía de esfuerzo) y en caso de estar alterado, se sigue con una coronariografía, para decidir cómo revascularizar (by-pass coronario vs angioplastia coronaria, dependiendo del número de vasos afectados). La ecocardiografía estaría indicada si hubiese síncopes, soplo u otra cosa que orientara a

estenosis aórtica o miocardiopatía hipertrófica. La cintigrafía de perfusión miocárdica (talio dipiridamol), se pide, en lugar del test de esfuerzo, cuando el paciente no tolera el esfuerzo, está amputado o cuando hay un BCRI.

Fuente: Cardiología, cuestionario 10.5, P3

36. Un paciente de 69 años, dislipidémico e hipertenso, consulta en la urgencia por dolor torácico, de carácter opresivo, intenso, que se asocia a sudoración y malestar. Al examen físico presenta signos vitales normales con murmullo pulmonar presente, sin otros ruidos en el examen pulmonar y se ausculta un ritmo regular en 3 tonos, por presencia de un R4, en el examen cardiaco. Se solicita un electrocardiograma, que muestra inversión de la onda T en las derivaciones DII, DIII y AVF. La conducta inmediata más adecuada es:

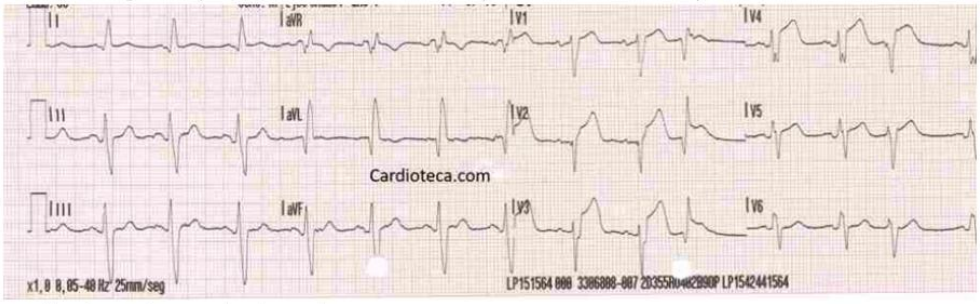
a. Realizar trombolisis de urgencia
b. Realizar cintigrafía de perfusión miocárdica
c. Realizar test de esfuerzo
d. Solicitar radiografía de tórax y administrar aspirina y captopril
e. Administrar oxígeno, nitroglicerina y aspirina, solicitar troponinas plamáticas y hospitalizar

Respuesta correcta: e. Administrar oxígeno, nitroglicerina y aspirina, solicitar troponinas plamáticas y hospitalizar

Explicación: Es un síndrome coronario agudo (SCA): dolor torácico opresivo, con R4 y antecedentes de factores de riesgo cardiovascular. Además, el EKG muestra signos de isquemia en la pared inferior (inda T invertida en DII, DIII y AVF). Como no hay supradesnivel del segmento ST, el diagnóstico es un SCA sin SDST, que se maneja con el manejo general y angioplastia, en el caso de que sea de alto riesgo (por score de TIMI, tiene 2 puntos: edad mayor a 65 años y FR cardiovascular). Sin embargo, está absolutamente contraindicada la trombólisis. De las alternativas, la E es la única aceptable, ya que supone el manejo del SCA. La trombólisis sería correcta, si hubiese habido un SDST o un BCRI.

Fuente: Cardiología, cuestionario 10.5, P11

37. Acude al servicio de urgencia un paciente de 55 años, con antecedente de hipertensión arterial esencial, en tratamiento con dieta y enalapril 20 mg/día, debido a sensación de opresión precordial, asociado a dolor 4/10. Los síntomas iniciaron hace 1 hora y se han mantenido. Al examen físico está en buenas condiciones generales, bien perfundido, con FC: 90x', PA: 150/100 mnHg, satura 98% a FiO2 ambiental RR2T sin soplos, MP(+) con escasos crépitos basales. Se solicita un electrocardiograma, que se muestra a continuación (fuente: cardioteca.com). ¿Cuál es la conducta más adecuada?



a. Solicitar angioTAC de tórax
b. Anticoagular con heparina y administrar verapamilo endovenoso
c. Realizar maniobras vagales y, si no revierte, administrar adenosina endovenosa en bolo

d. Iniciar morfina, oxígeno, nitroglicerina y aspirina y controlar con troponinas y electrocardiogramas seriados

e. Iniciar aspirina, oxígeno y nitroglicerina y realizar angioplastia de urgencia

Respuesta correcta: e. Iniciar aspirina, oxígeno y nitroglicerina y realizar angioplastia de urgencia

Explicación: Tiene un síndrome coronario agudo con SDST de pared anterior. Requiere revascularización de manera urgente, idealmente con angioplastia (si no está disponible, se trombolíza). Actualmente no se recomienda la morfina (ya no se da la MANO y la nemotecnia actual es muy fea como para repetirla en el curso), a menos que siga con dolor muy intenso que no responda a la nitroglicerina. Sí es correcto controlar con electrocardiogramas y marcadores de isquemia miocárdico seriados, pero el electrocardiograma actual ya es categórico, por lo que lo más correcto y urgente es revascularizar de inmediato.

Fuente: Cardiología, cuestionario 10.6, P2

38. Un paciente de 68 años, hipertenso, presenta angina de pecho, que aparece al caminar dos cuadras y que cede con el reposo. Su examen físico es normal, al igual que su electrocardiograma. La conducta más adecuada es:

a. Solicitar troponinas plasmáticas

b. Solicitar test de esfuerzo

c. Solicitar ecocardiograma

d. Solicitar radiografía de tórax

e. Realizar angioplastia

Respuesta correcta: b. Solicitar test de esfuerzo

Explicación: La angina crónica se diagnostica con la clínica y se estudia con test de esfuerzo, para determinar el pronóstico y la necesidad de revascularización. Luego, se suele hacer una coronariografía para determinar la vía de revascularización (angioplastía si hay enfermedad de 1 o 2 vasos; o by-pass coronario, si hay enfermedad de 3 vasos, de 2 vasos con compromiso de la arteria descendente anterior o en zonas en que no se puede instalar un stent: tronco coronaria izquierda, ostium). El test de esfuerzo convencional suele tener mejor rendimiento, por lo que suele ser de elección (caminata más electrocardiograma de 12 derivaciones). Sin embargo, en algunos casos (BCRI, amputado, paciente que no tolera el ejercicio), se puede reemplazar por imágenes de esfuerzo, como la ecocardiografía-dobutamina o la cintigrafía miocárdica con talio y dipiridamol.

Fuente: Cardiología, cuestionario 10.6, P10

Insuficiencia cardíaca y miocardiopatías (10)

39. Un paciente de 28 años consulta por angina de pecho, que aparece al caminar 2 cuadras. Además, presenta ortopnea y al examen físico se objetiva pulso amplio y un soplo sistólico eyectivo. El diagnóstico más probable es:

a. Miocardiopatía hipertrófica

b. Miocardiopatía dilatada

c. Estenosis aórtica

d. Insuficiencia mitral

e. Válvula aórtica bicúspide

Respuesta correcta: a. Miocardiopatía hipertrófica

Explicación: Tiene la clínica clásica de miocardiopatía hipertrófica obstructiva: angina de pecho, clínica de insuficiencia cardiaca, pulso Celler o amplio (también se ve en la insuficiencia aórtica) y soplo sistólico eyectivo. No es estenosis aórtica por la edad (la estenosis aórtica es de adulto mayor, aunque puede ser de paciente menor si hablamos de estenosis aórtica congénita) ni por el pulso (el pulso de la estenosis aórtica es parvus et tardus).

Fuente: Cardiología, cuestionario 10.1, P4

40. ¿Qué fármacos aumentan la sobrevida en los pacientes con insuficiencia cardíaca congestiva?

a. IECAs, espironolactona y betabloqueantes
b. IECAs, digitálicos y furosemida
c. Betabloqueantes, digitálicos y bloqueadores del calcio no dihidropiridinicos
d. Betabloqueantes, amiodarona y bloqueadores del calcio dihidropiridínicos
e. Digitálicos, furosemia y aspirina

Respuesta correcta: a. IECAs, espironolactona y betabloqueantes

Explicación: Los IECA o ARA2, la espironolactona y betabloqueo, aumentan la sobrevida. Los IECA / ARA2 y el betabloqueador se indican en la mayoría de pacientes. La espironolactona se usa en pacientes con fracción de eyección menor a 35% más síntomas, a pesar de los otros fármacos. También se debe tratar la causa de base. El tratamiento estándar suele ser enalapril o losartán, carvedilol y furosemida con o sin espironolactona. Los digitálicos y la furosemida solamente disminuyen los síntomas. En la práctica, la furosemida se usa en la mayoría de pacientes. La digoxina, en cambio, por tener muchos efectos adversos, casi no se recomienda actualmente. Los otros medicamentos, como la amiodarona, bloqueadores de calcio y aspirina solo aumentan la sobrevida, cuando la causa de base está siendo tratada con esos medicamentos: ejemplo, la amiodarona aumenta la sobrevida en la fibrilación auricular, los bloqueadores de calcio aumentan la sobrevida en hipertensión arterial y la aspirina aumenta la sobrevida en la cardiopatía coronaria.

Fuente: Cardiología, cuestionario 10.1, P11

41. Paciente de 35 años sin antecedentes de importancia consulta por cuadro de 4 meses de evolución caracterizado por disnea de esfuerzos progresiva actualmente de moderados esfuerzos, ortopnea y disnea paroxística nocturna. Al examen orientado, yugulares ingurgitadas a 45°, edemas en ambas extremidades inferiores ++, FC 100, PA 130/75, Sat 95% a O2 ambiental, al examen cardiaco destaca choque de la punta desplazado, RR3T por la presencia de un tercer ruido, soplo sistólico en ápex, al examen pulmonar destacan crepites escasos en ambas bases y al examen abdominal hepatomegalia. Rx torax destaca cardiomegalia y ECG muestra signos de hipertrofia ventricular izquierda. ¿Diagnóstico más probable?

a. Insuficiencia cardíaca de origen coronario
b. Miocardiopatía hipertrófica
c. Miocardiopatía dilatada
d. Cardiopatía hipertensiva
e. Enfermedad de Takotsubo

Respuesta correcta: c. Miocardiopatía dilatada

Explicación: Tiene clínica de ICC tanto izquierda (disnea paroxística, disnea de esfuerzo y ortopnea), como derecha (edema de EEII, ingurgitación yugular y hepatomegalia). Además, por tener cardiomegalia, es muy sugerente de una MCP dilatada (en especial por la edad joven). Recordar que tanto MCP dilatada, como hipertrófica tienen signos de HTVI en el EKG. No tiene FR cardiovascular, como para pensar en cardiopatía coronaria. No tiene antecedente de HTA como para pensar en cardiopatía hipertensiva

(además que esta cursa sin caediomegalia). La enfermedad de Takotsubo es una miocardiopatía rara y transitoria, que produce dolor torácico e insuficiencia cardíaca, en relación a estrés marcado (ej. La muerte de un ser querido: por eso también se llama síndrome del corazón roto). Tiene buen pronóstico y el EKG muestra signos de infarto de pared anterior y apical, pero la coronariografía es normal.

Fuente: Cardiología, cuestionario 10.2, P3

42. Un paciente de 60 años, diagnosticado de insuficiencia cardíaca por cardiopatía hipertensiva y de diabetes mellitus 2, está en tratamiento con enalapril 20 mg cada 12 horas, carvedilol 12,5 mg cada 12 horas, furosemida 20 mg cada 12 horas y metformina 850 mg cada 12 horas. Acude a control y refiere aumento de su disnea basal, la que ahora aparece al caminar una cuadra. Sus signos vitales son normales y su examen físico muestra RR2T sin soplos y MP(+) con escasos crépitos bibasales. ¿Qué conducta es la más adecuada para mejorar el pronóstico de este paciente?

a. Agregar espironolactona al tratamiento
b. Agregar digoxina al tratamiento
c. Agregar amiodarona al tratamiento
d. Remplazar el enalapril por losartán
e. Remplazar el carvedilol por propanolol

Respuesta correcta: a. Agregar espironolactona al tratamiento

Explicación: Es una ICC y se pregunta por el pronóstico, así que lo más adecuada es iniciar algo que aumente la sobrevida. La espironolactona aumenta la sobrevida, al igual que el betabloqueo y los IECA. La indicación más clara de la espironolactona es el paciente con fracción de eyección menor a 35% (es importante realizar el ecocardiograma tanto para pronóstico como para definir el tratamiento) más presencia de síntomas, a pesar del uso de betabloqueo y IECA o ARA2. Actualmente también sirve agregar los SGLT-2, como la dapaglifozina (es un hipoglicemiante, pero que aumenta la sobrevida en pacientes con ICC). - La digoxina solo disminuye los síntomas, al igual que los diuréticos. - La amiodarona solo está indicada, si es que además hay una fibrilación auricular. - Los ARA2 actualmente se pueden indicar indistintamente con el IECA, pero solo se indica uno de ellos. Solo si el IECA hubiese producido tos o angioedema, habría sido necesario cambiarlo por el ARA2. - El carvedilol es mejor que el propanolol en la ICC, por lo que no debe ser reemplazado por este.

Fuente: Cardiología, cuestionario 10.3, P1

43. Un paciente de 36 años consulta por disnea de esfuerzos, que inició hace un mes y que ha ido en aumento, apareciendo ante pequeños esfuerzos. Además, refiere que debe dormir semisentado, ya que de lo contrario se ahoga y que en ocasiones despierta "sin aire" por lo que debe levantarse y respirar profundo antes de poder dormirse nuevamente. Al examen físico se aprecia pulso regular a 80x', presión arterial de 110/70 mmHg, desplazamiento del choque de la punta y se ausculta un soplo sistólico. El electrocardiograma muestra signos de hipertrofia del ventrículo izquierdo, sin otras alteraciones y la radiografía de tórax demuestra cardiomegalia importante. El diagnóstico más probable es:

a. Miocardiopatía hipertrófica
b. Miocardiopatía dilatada
c. Cardiopatía hipertensiva
d. Estenosis aórtica
e. Insuficiencia aórtica

Respuesta correcta: b. Miocardiopatía dilatada

Explicación: La clínica muestra síntomas de ICC izquierda (disnea, ortopnea y disnea paroxística nocturna), más soplo sistólico y cardiomegalia. Además, por ser un paciente joven, lo más probable es que sea un MCP dilatada. El soplo es por insuficiencia mitral, secundaria a la dilatación del anillo mitrálico. La estenosis aórtica y la MCP HT sí tienen la ICC izquierda y el soplo sistólico (mesosistólico), pero no tienen cardiomegalia, sino una HT concéntrica. La cardiopatía hipertensiva no tiene cardiomegalia ni soplo y debe tener el antecedente de HTA. En el examen sí puede tener un R2 aumentado. La insuficiencia aórtica tiene ICC izquierda y cardiomegalia, pero su soplo es diastólico.

Fuente: Cardiología, cuestionario 10.3, P6

44. Un paciente de 40 años consulta por disnea de esfuerzo, que aparece al caminar una cuadra. Refiere que los síntomas iniciaron hace un mes, pero que eran mucho más leves. Además, presenta disnea paroxística nocturna y algún grado de ortopnea. Al examen físico se aprecia edema de extremidades inferiores, se ausculta un ritmo regular en 3 tiempos, por presencia de un R3 y se palpa desplazamiento del choque de la punta. ¿Cuál es el tratamiento más adecuado para este paciente?

a. Aspirina y IECA
b. IECA, propanolol e hidroclorotiazida
c. Propanolol, ARA II
d. IECA, carvedilol, espironolactona y furosemida
e. IECA y digoxina

Respuesta correcta: d. IECA, carvedilol, espironolactona y furosemida

Explicación: La clínica sugiere una miocardiopatía dilatada (MCP D): insuficiencia cardíaca izquierda (o global), cardiomegalia y disfunción sistólica (por el R3). Su tratamiento es el tratamiento de la ICC, con los fármacos que aumentan la sobrevida (1. IECAs o ARA-2, 2. betabloqueo: de elección el carvedilol y 3. espironolactona) y los que disminuyen los síntomas (1. furosemida y 2. digoxina, aunque su uso está limitado por su rango terapéutico estrecho). - En este caso, además tiene síntomas, por lo que está en etapa C, en la que se inicia la espironolactona (tiene evidencia en fracción de eyección baja, menor a 35%, más síntomas a pesar del uso de los demás fármacos) - En cambio, en la etapa B (solo cambios estructurales), bastan los IECA y el betabloqueo. De todas las opciones, la mejor es la D, aunque también habría sido correcto indicar IECA/ARA-2, carvedilol y furosemida, sin la espironolactona, ya que no indican el valor de la fracción de eyección. - Además, en casos más graves, se evalúa indicar un marcapasos de resincronización miocárdica (además, vienen con DAI, por si hay arritmias) e incluso el trasplante cardíaco.

Fuente: Cardiología, cuestionario 10.4, P4

45. Un paciente de 38 años consulta por angina de pecho, que aparece al caminar 2 cuadras. Además presenta ortopnea y al examen físico se ausculta un soplo sistólico eyectivo que disminuye al ponerse en cuclillas y aumenta a la bipedestación. El diagnóstico más probable es:

a. Miocardiopatía hipertrófica
b. Miocardiopatía dilatada
c. Estenosis aórtica
d. Insuficiencia mitral
e. Válvula aórtica bicúspide

Respuesta correcta: a. Miocardiopatía hipertrófica

Explicación: La angina, la ortopnea y el soplo son característicos, tanto de la MCP HT, como de la estenosis aórtica. Así que la diferencia es por la edad (joven sugiere más MCP HT) y por el soplo, que en la MCP HT

disminuye con las cuclillas y aumenta al ponerse de pie y con la maniobra de Valsalva, mientras que en la estenosis aórtica pasa lo contrario.

Fuente: Cardiología, cuestionario 10.5, P4

46. ¿Cuál es el tratamiento más adecuado para un paciente con una insuficiencia cardíaca por Miocardiopatía Dilatada, en capacidad funcional III?

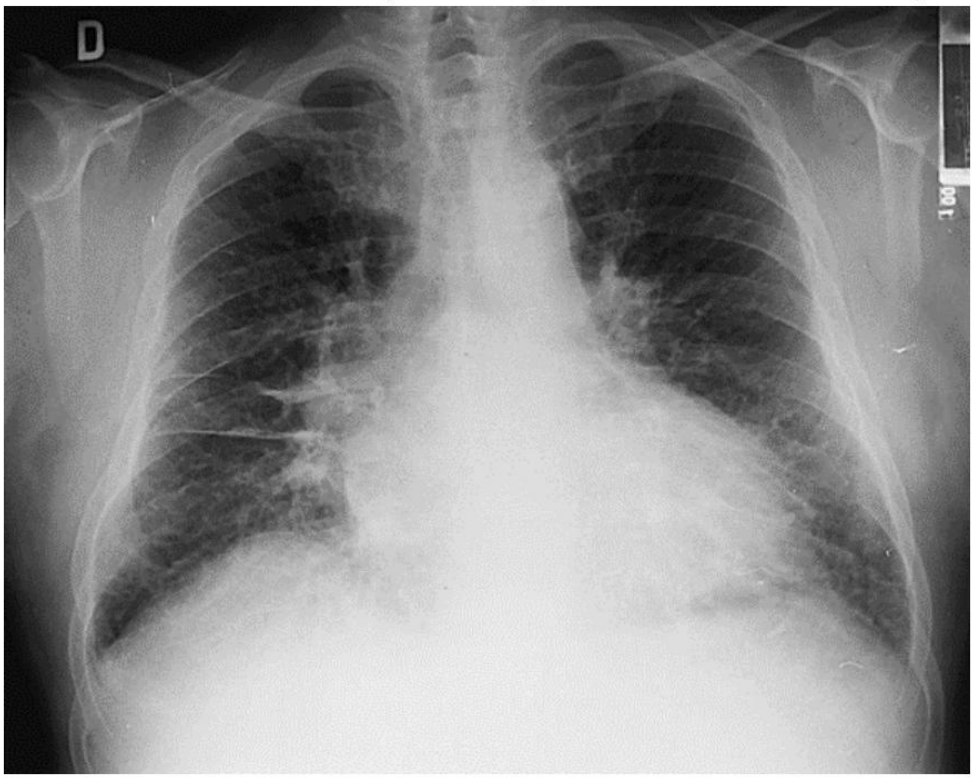
a. Aspirina, enalapril y atenolol
b. Aspirina, captopril, furosemida y carvedilol
c. Enalapril, carvedilol y furosemida
d. Digoxina, furosemida y losartán
e. Digoxina, furosemida y acenocumarol

Respuesta correcta: c. Enalapril, carvedilol y furosemida

Explicación: La MCP dilatada se trata como una insuficiencia cardíaca (ICC) común y corriente, más el tratamiento de la causa, en el caso de ser secundaria (a alcoholismo o Chagas, por ejemplo). El tratamiento de la ICC consiste en fármacos que aumentan la sobrevida (IECAs o ARA2, betabloqueo y espironolactona) y fármacos que disminuyen los síntomas (furosemida en la mayoría y digoxina en casos seleccionados). - El enalapril es el fármaco más usado y con mayor impacto en la sobrevida. El captopril, en cambio, tiene una vida media demasiado corta. - El betabloqueante de elección es el carvedilol (con efecto anti alfa1, además). - Desde la etapa B (solo cambios estructurales), ya se inician los IECA y el betabloqueo. - En este caso, por estar en capacidad funcional III (disnea de reposo), equivale a la etapa C de la ICC (con síntomas), por lo que el tratamiento mínimo suele ser enalapril + carvedilol + furosemida. La espironolactona se debe agregar en casos con fracción de eyección <35% más síntomas a pesar de IECA y betabloqueo. - En la etapa D, además, se debe evaluar si se instala un marcapasos de resincronización o si se realiza un trasplante cardíaco.

Fuente: Cardiología, cuestionario 10.5, P10

47. Un paciente de 42 años presenta disnea de esfuerzos de 2 meses de evolución, que ha ido en aumento, asociado a ortopnea. No tiene antecedentes de importancia y no consume fármacos. Sus signos vitales son FC: 70x', PA: 110/70 mmHg, FR: 15x', saturación arterial de oxígeno: 95%. Al examen físico se constata ritmo regular en 3 tonos, con presencia de tercer ruido, sin soplos y el examen pulmonar muestra crepitaciones bilaterales, mayores en las bases. Se solicita radiografía de tórax, que se muestra a continuación (fuente: https://www.cardiomedica.es/). ¿Cuál es el diagnóstico más probable?



a. Neumonía por Pneumocystis jirovecii
b. Neumonía por Mycoplasma pneumoniae
c. Cardiomiopatía dilatada
d. Comunicación interventricular
e. Tuberculosis pulmonar

Respuesta correcta: c. Cardiomiopatía dilatada

Explicación: Tiene una miocardiopatía dilatada clásica, con clínica de insuficiencia cardíaca izquierda (disnea de esfuerzo, ortopnea y DPN) más la cardiomegalia en la radiografía de tórax y presencia de R3 (disfunción sistólica; también puede tener R4, aunque se ve más en otras patologías con disfunción sistólica). La radiografía muestra cardiomegalia, hilios prominentes y líneas B de Kerley.

Fuente: Cardiología, cuestionario 10.6, P4

48. Un paciente de 66 años, con antecedente de cardiopatía hipertensiva, en capacidad funcional II, consulta por disnea de grandes esfuerzos, que ha progresado en los últimos 6 meses. No ha tenido otros síntomas y adhiere a la dieta y tratamiento farmacológico: enalapril 20 mg c/12 horas y furosemida 40 mg/día. Sus signos vitales son normales y su examen cardiopulmonar solo muestra escasos crépitos bibasales. El ecocardiograma muestra una fracción de eyección de 50%. ¿Qué ajuste farmacológico es recomendable hacer?

a. Reemplazar el enalapril por losartán
b. Reemplazar la furosemida por hidroclorotiazida
c. Agregar espironolactona
d. Agregar carvedilol
e. Agregar diltiazem

Respuesta correcta: d. Agregar carvedilol

Explicación: Tiene una insuficiencia cardíaca por cardiopatía hipertensiva, por lo que se debe tratar tanto la hipertensión arterial como la insuficiencia cardíaca. La HTA parece bien manejada, con el enalapril, ya que sus signos vitales están normales. La ICC está bien tratada con enalapril (que aumenta la sobrevida) y la furosemida (que solo disminuye los síntomas), sin embargo, aún se puede agregar betabloqueo para aumentar la sobrevida, en especial, el carvedilol que bloquea receptores alfa-1 y beta-1 y 2, por lo que tiene mejor acción sobre la remodelación cardíaca que los betabloqueantes sin acción alfa. La espironolactona también aumenta la sobrevida, pero se usa en casos sintomáticos, a pesar de estar con IECAs/ARA-2 y betabloqueo, más una fracción de eyección menor a 35%.

Fuente: Cardiología, cuestionario 10.6, P5

Arritmias y síncope (17)

49. Un paciente de 40 años consulta por palpitaciones intensas, de media hora de evolución. Al examen físico presenta pulso regular a 150 lpm. Se solicita un electrocardiograma, que muestra una taquicardia regular a 150x', con QRS angosto, por lo que se inicia masaje carotideo, logrando una disminución de la FC a 70 lpm, presentado de inmediatamente el siguiente electrocardiograma: El diagnóstico más probable es:

a. Taquicardia sinusal
b. Fibrilación auricular
c. Taquicardia ventricular
d. Taquicardia paroxística supraventricular
e. Flutter auricular

Respuesta correcta: e. Flutter auricular

Explicación: El electrocardiograma muestra las ondas P en forma de serrucho características, en las derivaciones inferiores, DII y DIII. El que haya bajado la frecuencia cardiaca con el masaje carotídeo, es característico de la TPSV, pero en ese caso mostraría un ritmo sinusal y no las ondas P de serrucho. En el flutter la FC cae de manera transitoria con el masaje carotideo, luego retoma a 150 por minuto.

Fuente: Cardiología, cuestionario 10.1, P7

50. Una paciente de 69 años, portadora de una insuficiencia cardiaca, secundaria a una cardiopatía hipertensiva, consulta por marcada disnea y síncopes. Al examen físico presenta FC: 160 lpm, irregular y PA: 70/40 mmHg. El monitor electrocardiográfico es compatible con una fibrilación auricular de respuesta ventricular rápida. La conducta más adecuada es:

a. Realizar cardioversión eléctrica de inmediato
b. Administrar heparina endovenosa y solicitar ecocardiograma transesofágico
c. Administrar propafenona endovenosa
d. Administrar lanatósido C endovenoso
e. Administrar amiodarona endovenosa

Respuesta correcta: a. Realizar cardioversión eléctrica de inmediato

Explicación: Por ser una taquiarritmia, con hemodinamia inestable, a respuesta correcta es cardioversión eléctrica de inmediato. Esto es lo más importante. Si hubiese estado con hemodinamia estable, sería correcto el ecocardiograma transesofágico para descartar trombos, antes de cardiovertir. La heparina se inicia actualmente en prácticamente todas las FA de reciente diagnóstico (excepto que esté contraindicada o que haya sido autolimitada y de menos de 24-48 horas, en un paciente sin criterios de CHASD2-VAS). Posteriormente, se decide la anticoagulación a permanencia, según los criterios CHASD2-VAS. Los demás fármacos se habrían podido usar si hubiese estado con hemodinámica estable: - La propafenona endovenosa, se usa en la cardioversión farmacológica en corazón sano. La amiodarona en corazón enfermo (como en este caso que tiene cardiopatía hipertensiva) y en pacientes con corazón sano también se puede usar. * La cardioversión farmacológica (en hemodinámica estable) se realiza después de 3-4 semanas de anticoagulación o antes, si es que el ecocardiograma transesofágico descarta trombos (lo ideal). El lanatósido C sería correcta, ya que esta taquicárdica, pero solo si la paciente está con hemodinamia estable, ya que, estando inestable, se debe cardiovertir eléctricamente de inmediato.

Fuente: Cardiología, cuestionario 10.1, P8

51. Un paciente en fibrilación auricular puede mostrar todo lo siguiente, EXCEPTO:

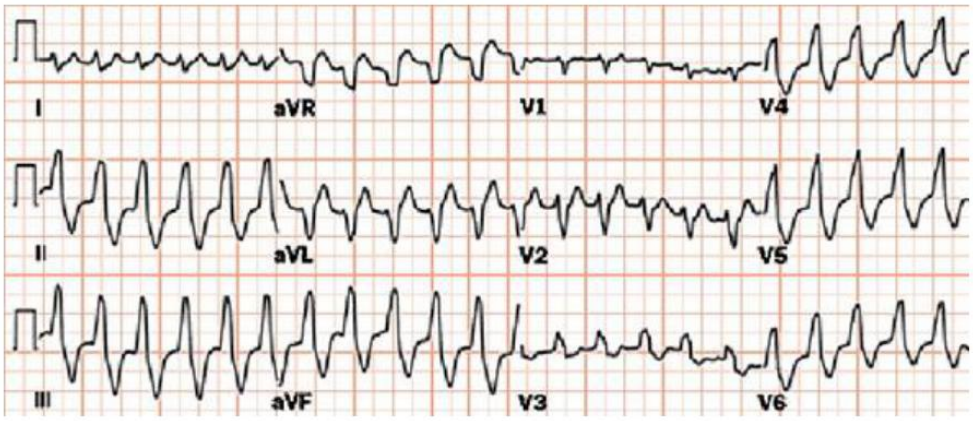
a. Ausencia de onda “P”
b. Ausencia de onda “a”
c. Soplo sistólico
d. Soplo diastólico
e. R4

Respuesta correcta: e. R4

Explicación: La fibrilación auricular elimina la contracción auricular, por lo que se pierde la onda P (depolarización de la aurícula) en el EKG y no puede haber ni onda “a” del pulso venoso, ni R4, ya que ambos son producidos por la contracción auricular. El soplo no es característico de la FA, pero sí puede estar presente, según la patología de base que exista.

Fuente: Cardiología, cuestionario 10.1, P19

52. Un paciente de 69 años, con antecedente de un infarto miocárdico hace 2 años, consulta por palpitaciones, asociado a disnea. Al examen físico presenta sudoración, PA: 90/60 y FC: 150 x'. Se solicita un electrocardiograma que se muestra a continuación:



a. Nuevo infarto miocárdico
b. Aneurisma ventricular
c. Taquicardia ventricular
d. Fibrilación auricular
e. Flutter auricular

Respuesta correcta: c. Taquicardia ventricular

Explicación: Tiene una taquiarritmia con QRS ancho, lo que es diagnóstico de una taquicardia ventricular. El antecedente de IAM antiguo también orienta y el compromiso hemodinámico obliga a cardiovertir eléctricamente de inmediato (con 100 joules en un adulto).

Fuente: Cardiología, cuestionario 10.1, P20

53. Un paciente de 60 años, sin antecedentes, consulta por palpitaciones intensas, de media hora de evolución. Al examen físico presenta pulso regular a 150 lpm y PA de 60/20 mmHg. Se solicita un electrocardiograma, que muestra una taquicardia regular a 150x', con ondas P de serrucho. El tratamiento más adecuado para el manejo de este paciente es:

a. Propanolol
b. Digoxina
c. Amiodarona
d. Cardioversión eléctrica
e. Propafenona

Respuesta correcta: d. Cardioversión eléctrica

Explicación: El EKG muestra un flutter auricular, a una frecuencia cercana a 150 lpm (300/2; el número de cuadraditos entre dos QRS es 2). Sin embargo, lo que importa es que tiene una taquiarritmia con hemodinamia inestable (está hipotenso), por lo que se tiene que cardiovertir eléctricamente de inmediato. Si hubiese tenido una hemodinamia estable, lo primero habría sido disminuir la FC con propanolol o digoxina y luego cardiovertirlo farmacológicamente con amiodarona o propafenona.

Fuente: Cardiología, cuestionario 10.2, P1

54. Un paciente de 69 años, con antecedente de un infarto miocárdico hace 2 años, consulta por palpitaciones, asociado a disnea. Al examen físico presenta sudoración, PA: 110/70 y FC: 150 x'. Se solicita

un electrocardiograma que se muestra a continuación (fuente: https://cardioparamap.com/2016/11/28): La conducta más adecuada es:

a. Administrar adenosina endovenosa
b. Cardiovertir eléctricamente de inmediato
c. Administrar amiodarona endovenosa
d. Administrar propanolol y heparina por vía endovenosa
e. Desfibrilar eléctricamente de inmediato

Respuesta correcta: c. Administrar amiodarona endovenosa

Explicación: Si bien el antecedente de IAM antiguo orienta a TV, lo único que se debe considerar para responder es el EKG, que en este caso muestra una taquiarritmia regular, con QRS ancho, es decir, una TV clásica. En este caso es monomorfa. * Su manejo, suele ser con cardioversión eléctrica inmediata ya que suelen tener hemodinamia inestable. Sin embargo, en este caso, está con hemodinamia estable desde el punto de vista clínico, por lo que se recomienda primero intentar cardiovertir con amiodarona, procaínamida o lidocaína por vía endovenosa. * Dado que tiene una causa de base y que el riesgo de recurrencia es muy alto, deberá quedar con profilaxis con amiodarona a permanencia más, idealmente, un desfibrilador automático implantable. La TPSV se maneja con maniobras vagales y adenosina. La idea general es que las arritmias ventriculares tienen QRS ancho, mientras que las supraventriculares (fibrilación auricular, flutter auricular, TPSV) tienen QRS angosto (salvo los casos con aberrancia: BCRI o BCRD).

Fuente: Cardiología, cuestionario 10.2, P6

55. Un paciente de 65 años, con antecedente de un infarto agudo al miocardio hace un año, consulta por palpitaciones y disnea. Al examen físico presenta frecuencia cardíaca 150x', con PA: 110/70 mmHg. Se solicita un electrocardiograma que muestra una taquicardia regular con complejos QRS anchos (0,20 segundos). La conducta más adecuada es:

a. Administrar propafenona endovenosa
b. Administrar propanolol endovenoso
c. Administrar adenosina endovenosa
d. Administrar amiodarona endovenosa
e. Administrar lanatósido C endovenoso

Respuesta correcta: d. Administrar amiodarona endovenosa

Explicación: Tiene una taquicardia ventricular (TV), ya que tiene QRS anchos, mayores a 0,12 segundos. Por tanto debe tratarse con amiodarona o con lidocaína, que son los antiarrítmicos de elección para esta arritmia. Eso sí, es muy frecuente que lleguen con hemodinamia inestable (no en este caso) y que requiera de cardioversión eléctrica. Además, para evitar que recurra, suele quedar con betabloqueadores y, por si recurre, también debe instalarse un desfibrilador automático implantable (DAI). - La propafenona se usa en la fibrilación auricular (FA) en pacientes con corazón sano. - El lanatósido C (un tipo de digital), la digoxina y el propanolol se usan en la FA rápida de reciente diagnóstico, para bajar la frecuencia cardíaca. - La adenosina se usa en la taquicardia paroxística supraventricular (TPSV).

Fuente: Cardiología, cuestionario 10.3, P2

56. Un paciente de 45 años, hipertenso, consulta por palpitaciones de inicio súbito de una hora de evolución. Al examen está en buenas condiciones generales, con pulso de 80 lpm, irregular y presión arterial 120/80 mmHg. Se solicita un electrocardiograma que muestra una fibrilación auricular. La conducta más adecuada es:

a. Iniciar anticoagulación con heparina y solicitar ecocardiograma transesofágico de urgencia
b. Realizar cardioversión eléctrica de inmediato
c. Realizar masaje carotideo
d. Administrar verapamilo endovenoso
e. Realizar cardioversión farmacológica con propafenona

Respuesta correcta: a. Iniciar anticoagulación con heparina y solicitar ecocardiograma transesofágico de urgencia

Explicación: Tiene una fibrilación auricular de reciente diagnóstico, hemodinámicamente estable. En general se sigue tres pilares: 1. Normalizar la FC, 2. Anticoagular y 3 Cardiovertir farmacológicamente, una vez que se haya minimizado el riesgo de embolias. - En este caso tiene una FC de 80 lpm, lo que es normal, por lo que no requiere el control de FC (que se suele hacer con propanolol, verapamilo o digoxina por vía endovenosa). - La anticoagulación actualmente se recomienda en casi todos los pacientes, aunque en las primeras 48 horas es muy improbable que se formen trombos (el problema es que sí es posible que lleve más de 48 horas de FA, solo que no se haya dado cuenta el paciente). - El momento de la trombólisis se define después de que el ecocardiograma transesofágico haya descartado trombos auriculares. En caso de que no esté disponible, se puede cardiovertir en 3-4 semanas. Es aceptable cardiovertir sin un ecocardiograma transesofágico, siempre que lleve menos de 48 horas, pero las recomendaciones actuales sugieren hacer el ecocardiograma siempre. * La cardioversión farmacológica se puede hacer con amiodarona (pacientes con cardiopatía) o con propafenona o flecainamida (pacientes sin cardiopatía). En este caso, se sospecha que tenga una cardiopatía hipertensiva. * La cardioversión eléctrica habría sido correcta, si es que estuviese hemodinámicamente inestable. * El masaje carotideo sería correcto si se tratara de una TPSV.

Fuente: Cardiología, cuestionario 10.3, P9

57. Un paciente consulta por palpitaciones intensas, de inicio súbito, asociados a disnea. Al examen está hemodinámicamente estable, con una frecuencia cardíaca de 180 lpm. Se solicita un electrocardiograma que muestra una taquicardia regular, a 180 lpm, con complejos QRS angostos y sin visualización de la onda P. ¿Cuál de los siguientes fármacos es más adecuado para el manejo inicial de este paciente?

a. Suero fisiológico
b. Amiodarona
c. Adenosina
d. Sulfato de magnesio
e. Gluconato de calcio

Respuesta correcta: c. Adenosina

Explicación: Tiene una TPSV, que se trata con maniobras vagales y luego con adenosina. Se dan hasta 3 dosis de adenosina. Si falla, se da verapamilo y si falla nuevamente, amiodarona. La última línea es la cardioversión eléctrica. La ausencia de onda P es característica de la fibrilación auricular, pero la FA es una arritmia irregular, a QRS angosto. En cambio la TPSV es una arritmia regular a QRS angosto, que puede tener onda P o no tenerla (porque queda dentro del QRS). El sulfato de magnesio se usa para la torsades de pointes. El gluconato de calcio sirve para la hiperkalemia, la hipermagnesemia y la hipocalcemia.

Fuente: Cardiología, cuestionario 10.4, P2

58. Un paciente de 80 años, hipertenso en tratamiento con atenolol, presenta palpitaciones desde hace un mes. Al examen físico se palpa un pulso irregular y su electrocardiograma muestra una fibrilación auricular de respuesta ventricular lenta, a 70 lpm. Está en buenas condiciones. La conducta más adecuada es:

a. Indicar aspirina
b. Indicar anticoagulación con rivaroxabán
c. Indicar clopidogrel
d. Suspender el atenolol e iniciar un IECA
e. Observar evolución

Respuesta correcta: b. Indicar anticoagulación con rivaroxabán

Explicación: Es una FA crónica. Está con atenolol desde antes y su FC está controlada (el objetivo del control de frecuencia es mantenerla entre 60 y 90 lpm), por lo que no es necesario dar control de frecuencia ni de ritmo. Para decidir si se quedará con anticoagulación oral (cumarínicos o nuevos anticoagulantes), es necesario calcular el puntaje CHADS2-VAS: en este caso es mayor de 75 años (1 punto + 1 punto VAS) e hipertenso (1 punto), por lo que tiene un puntaje total de 3 puntos, lo que obliga la anticoagulación. Por la edad, idealmente se debe indicar un nuevo anticoagulante oral. La aspirina, eventualmente se podría dar, por tener alto riesgo cardiovascular (HTA y edad avanzada), pero, en los casos en que está anticoagulado, no suele indicarse el tratamiento antiagregante, salvo que haya un riesgo muy elevado de trombosis.

Fuente: Cardiología, cuestionario 10.4, P12

59. Un paciente de 79 años presenta un síncope de cerca de 40 segundos de duración, mientras estaba sentado en la mesa. Los familiares que presenciaron el episodio refieren que estaba tranquilo conversando, cuando súbitamente perdió la consciencia y se golpeó con la mesa, recuperándose por completo unos segundos después. No presentó otros síntomas. ¿Cuál es la causa más probable de su síncope?

a. Vasovagal
b. Cardiogénico
c. Neurológico
d. Conversivo
e. Disautonómico

Respuesta correcta: b. Cardiogénico

Explicación: Es un síncope de reposo, por lo que lo más probable es que se trate de un síncope cardiogénico. - Los síncopes vasovagales se caracterizan por un prodromo sintomático de malestar, parestesias, náuseas, etc. - El cardiogénico suele ser de reposo (típico de las bradiarritmias, aunque también se puede ver en arritmias ventriculares autolimitadas) o relacionado con el esfuerzo (taquiarritmias, por ejemplo en estenosis aórtica o MCP hipertrófica). Las arritmias graves y que se mantienen en el tiempo suelen presentarse como muerte súbita o shock cardiogénico, en lugar de un simple síncope. - El neurológico, es clásico de las crisis atónicas y se caracteriza por pérdida del control de esfínteres. - El conversivo suele no golpearse y estar en relaciones al estrés. - El disautonómico incluye al vasovagal y al situacional (que suele ser después de orinar o de defecar).

Fuente: Cardiología, cuestionario 10.4, P14

60. ¿Cuál de los siguientes pacientes NO necesita antiarrítmicos como betabloqueantes, amiodarona, lidocaína, etc.?

a. Paciente cursando un infarto miocárdico, que inicia con extrasístoles ventriculares frecuentes en su electrocardiograma

b. Paciente con antecedente de un infarto hace 6 meses, que presenta extrasístoles ventriculares frecuentes en su electrocardiograma

c. Paciente con extrasístoles ventriculares frecuentes, que aparecen luego de realizar una agioplastía por un infarto miocárdico

d. Paciente con miocardiopatía hipertrófica, que presenta extrasístoles ventriculares frecuentes en su electrocardiograma

e. Paciente con miocardiopatía dilatada, que presenta extrasístoles ventriculares frecuentes en su electrocardiograma

Respuesta correcta: c. Paciente con extrasístoles ventriculares frecuentes, que aparecen luego de realizar una agioplastía por un infarto miocárdico

Explicación: - Las ESV en pacientes sanos y asintomáticos, simplemente se observan. - Las ESV, en contexto de IAM, pueden observarse si es que son asintomáticas y escasas. Sin embargo, si es que son muy frecuentes o complejas (salvas de 3 o más), tienen elevadísimo riesgo de evolucionar a una taquicardia ventricular (TV), por lo que requieren fármacos (betabloqueo o amiodarona). - Las ESV en contexto de cardiopatías (B, D y E) se asocian a desarrollo de taquicardia ventricular, por lo que se tratan con betabloqueo y, si no responden, con ablación con catéter o amiodarona. Se debe evaluar la necesidad de un desfibrilador automático implantable, si el riesgo de TV es demasiado alto. - Finalmente la C, es una arritmia de reperfusión (hasta 30 minutos postreperfusión), las que se observan, a menos que sea una TV mayor a 30 segundos.

Fuente: Cardiología, cuestionario 10.4, P16

61. Un paciente de 53 años presenta un síncope mientras comía con su familia. Al examen físico presenta bradicardia de 50 lpm, por lo que se solicita un electrocardiograma, que muestra una enfermedad del nodo sinusal. La conducta más adecuada es:

a. Observar evolución

b. Indicar marcapasos

c. Iniciar amiodarona

d. Solicitar un Holter de arritmias

e. Iniciar atenolol

Respuesta correcta: b. Indicar marcapasos

Explicación: Tiene una enfermedad del nodo sinusal (ENS) sintomática, por lo que está indicado el marcapasos. Por el contrario, la ENS asintomática simplemente se observa. Los síntomas más frecuentes de la ENS justamente son los síncopes de reposo.

Fuente: Cardiología, cuestionario 10.5, P13

62. Un paciente de 50 años, diabético e hipertenso, presenta una fibrilación auricular crónica, sin tratamiento. Acude a control y refiere que ocasionalmente presenta palpitaciones y su frecuencia cardíaca basal es 100 x minuto, irregular. La conducta más adecuada es:

a. Indicar anticoagulación con cumarínicos e iniciar control de frecuencia con atenolol

b. Realizar cardioversión eléctrica

c. Solicitar un Holter de arritmias

d. Iniciar aspirina y control de ritmo con amiodarona

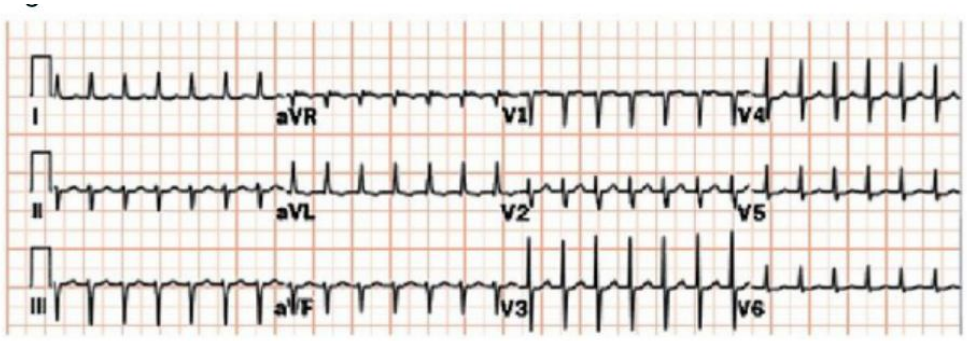
e. Solicitar ecocardiograma transesofágico, administrar heparina endovenosa y realizar cardioversión farmacológica en 2 semanas

Respuesta correcta: a. Indicar anticoagulación con cumarínicos e iniciar control de frecuencia con atenolol

Explicación: Tiene una FA crónica, en que se debe hacer todo lo siguiente: 1. Elegir entre control de frecuencia (con atenolol, verapamilo o digoxina; esta última con un rango terapéutico muy estrecho) y control de ritmo (con amiodarona: en cardiópatas o propafenona/flecainamida: en corazón sano). De ser posible lograr el objetivo, actualmente se prefiere intentar el control de ritmo, aunque sigue siendo aceptable el control de frecuencia (en este caso tiene frecuencia sobre 90, por lo que como mínimo se debe dar control de frecuencia). 2. Además, se debe elegir entre anticoagular o no hacerlo, según el CHADS2. En este caso es diabético e hipertenso, por lo que tiene 2 puntos del CHADS2, lo que obliga a iniciar anticoagulación, la que se puede hacer tanto con cumarínicos (TACO) como con los nuevos anticoagulantes orales (NACO o DACO, según si se usa la palabra "nuevos" o "directos"). 3. Tratar las demás patologías. En este caso, se deben indicar hipoglicemiantes, antihipertensivos, eventualmente aspirina si tiene alto riesgo cardiovascular (en los casos en que está anticogulado, se debe ponderar el riesgo de trombosis vs el de hemorragia, antes de mezclar aspirina y anticoagulantes). La alternativa A cumple con lo anterior, al anticoagular e indicar control de frecuencia. También habría sido correcto anticoagular con NACO y dejar control de ritmo. La B sería correcta si estuviera con hemodinamia inestable. La C es correcta en caso de que hubiese una sospecha de FA paroxística, con EKG normales (no es el caso, porque ya se diagnosticó). La D sería correcta si el CHADS 2 hubiese tenido un puntaje menor y alguna otra indicación de aspirina (ej. alto riesgo cardiovascular, que en este caso lo tiene). La E sería parcialmente correcta si fuese una FA aguda (se anticoagula y se pide el EcoTE para decidir si se cardiovierte ahora o en 3 a 4 semanas más).

Fuente: Cardiología, cuestionario 10.5, P17

63. Un paciente de 21 años consulta por disnea y palpitaciones de 20 minutos de evolución, que iniciaron súbitamente. Previo a esto había tenido otros episodios similares, pero que duraban mucho menos y se detenían también súbitamente. Su FC es 176 x' y su presión arterial es 130/90 mmHg. El resto del examen físico no aporta mayor información. Se solicita un electrocardiograma que muestra lo siguiente: El diagnóstico más probable es:



a. Fibrilación auricular

b. Flutter auricular

c. Taquicardia paroxística supraventricular

d. Taquicardia ventricular

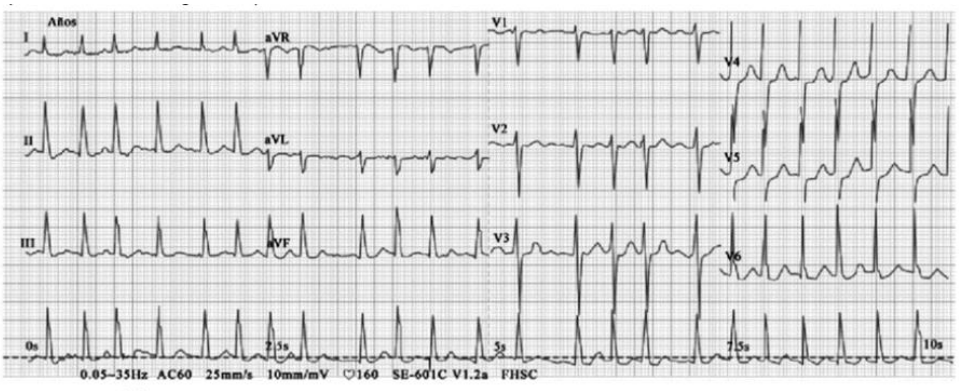
e. Taquicardia sinusal

Respuesta correcta: c. Taquicardia paroxística supraventricular

Explicación: El EKG muestra una taquicardia regular con QRS angosto. Además, no se ve la onda P. Por tanto es una TPSV. La FA sería irregular, con QRS angosto y sin onda P. El flutter auricular podría verse también como una taquiarritmia con QRS angosto, pero tendría ondas P de serrucho. La TV tendría QRS ancho. La taquicardia sinusal, obligatoriamente tiene onda P.

Fuente: Cardiología, cuestionario 10.5, P19

64. Un paciente de 67 años, con antecedente de hipertensión arterial y asma consulta por disnea y palpitaciones, que iniciaron hace 24 horas. Al examen físico tiene FC: 140x', irregular, FR: 20x', PA: 120/80 mmHg, murmullo pulmonar presente con escasos crépitos bibasales, sin sibilancias ni aumento del diámetro torácico, PEF: 95% del basal. Examen cardíaco con ritmo regular en dos tiempos, sin soplos. Se solicita electrocardiograma, que se muestra a continuación (fuente: https://www.researchgate.net). La primera medida es:



a. Cardioversión eléctrica inmediata
b. Propanolol endovenoso
c. Heparina endovenosa
d. Verapamilo endovenoso
e. Maniobras vagales

Respuesta correcta: d. Verapamilo endovenoso

Explicación: Tiene una fibrilación auricular de reciente comienzo, con respuesta ventricular rápida, con cierto compromiso cardíaco (insuficiencia cardíaca: disnea y crepitaciones), aunque hemodinámicamente estable, por lo que no requiere de cardioversión inmediata, sino de control de frecuencia urgente con verapamilo o propanolol (contraindicado por tener asma). Sí debe anticoagularse con heparina, pero lo primero es el control de la frecuencia, además que por llevar menos de 2 días es improbable que haya trombos y, sea como sea, no se va a cardiovertir aún. En el futuro probablemente quede anticoagulado, ya que tiene CHADS2-VAS con 2

Fuente: Cardiología, cuestionario 10.6, P6

65. Usted atiende a un paciente de 80 años, en control ambulatorio del adulto mayor. No ha tenido síntomas, sin embargo, trae electrocardiograma, tomado hace 2 semanas, que muestra una fibrilación auricular, con frecuencia cardíaca de 70 y sin signos de isquemia actual o antigua. Su examen físico solo muestra pulso irregular a 72x', sin otras alteraciones y sus demás exámenes de control son normales. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

a. Iniciar aspirina oral
b. Iniciar anticoagulación oral con inhibidores directos de la trombina o factor X activado
c. Observar evolución
d. Iniciar atenolol
e. Hospitalizar, anticoagular con heparina y administrar propafenona

Respuesta correcta: b. Iniciar anticoagulación oral con inhibidores directos de la trombina o factor X activado

Explicación: Tiene una fibrilación auricular crónica. Aunque tiene un reciente diagnóstico, no se identifica un momento de inicio, ya que no tiene síntomas y su electrocardiograma es de hace 2 semanas. Por tener 80 años, tiene 2 puntos en el CHADS2-VAS, por lo que requiere anticoagulación: los nuevos anticoagulantes orales se prefieren, en la medida que haya recursos, por sobre los cumarínicos. Por tener frecuencia cardíaca normal, no requiere de fármacos para el control de frecuencia, ya que dicho objetivo se ha cumplido. La aspirina actualmente no está indicada en la fibrilación auricular sin cardiopatía coronaria o sin alto riesgo cardiovascular (en ese caso la aspirina se da por el riesgo cardiovascular y no por la FA).

Fuente: Cardiología, cuestionario 10.6, P7

Electrocardiograma y trastornos electrolíticos (5)

66. Un paciente consulta por debilidad y astenia y parestesias peribucales. Al examen físico se constatan ROT exaltados y fasciculaciones y el electrocardiograma demuestra alargamiento del intervalo QT. El diagnóstico más probable es:

a. Hiponatremia
b. Hiperkalemia
c. Hipokalemia
d. Hipercalcemia
e. Hipocalcemia

Respuesta correcta: e. Hipocalcemia

Explicación: Tiene una hipocalcemia clásica (debilidad, parestesias peribucales, tetania con ROT aumentados, fasciculaciones y el característico alargamiento de QT). La hiponantremia tendría clínica de edema cerebral, la hiperkalemia tendría debilidad y un Electrocardiograma con ondas T picudas y ensanchamiento de QRS. La hipokalemia tendría debilidad, con alargamiento del QT, pero sin tetania ni parestesias. La hipercalcemia tendría compromiso de conciencia, acortamiento del QT, constipación, debilidad y poliuria.

Fuente: Cardiología, cuestionario 10.1, P13 · Cardiología, cuestionario 10.5, P7

67. Paciente 15 años sin antecedentes de importancia se realiza un chequeo médico por presentar dolor torácico en algunas ocasiones. Actualmente, está asintomático. Al examen físico destaca FC 68 lpm, PA 120/80, Sat O2 98% a aire ambiental, RR2TSS, MP (+) bilateral SRA. Se realiza ECG que destacan

extrasístoles ventriculares aisladas sin otras alteraciones. La conducta más adecuada frente a este hallazgo es:

a. Iniciar betabloqueo
b. Realizar holter de aritmias
c. Iniciar Procainamida
d. Prohibir la práctica de deporte
e. Explicar la condición encontrada, sin necesidad de mayor estudio

Respuesta correcta: e. Explicar la condición encontrada, sin necesidad de mayor estudio

Explicación: El dolor torácico no reviste ningún signo de alarma en este caso. El único hallazgo son las extrasístoles ventriculares frecuentes. El manejo de la ESV depende de la presencia de cardiopatía. Si es un paciente sano (como en este caso), simplemente se observa. En cambio, si es un paciente cardiópata, se debe iniciar betabloqueo o amiodarona, para prevenir la aparición de arritmias ventriculares más graves (ej. Taquicardia ventricular: recordar que una taquicardia ventricular es igual a varias ESV seguidas).

Fuente: Cardiología, cuestionario 10.2, P4

68. Un paciente hipertenso, se realiza un electrocardiograma de control, que muestra el siguiente trazado: La conducta más adecuada es:

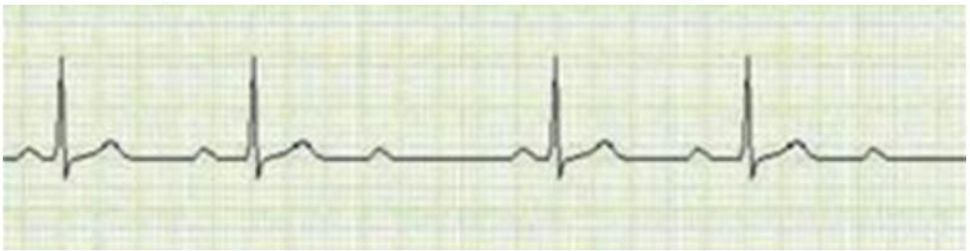
a. Solicitar un Holter de arritmias
b. Solicitar un test de esfuerzo
c. Indicar un marcapasos definitivo
d. Iniciar betabloqueantes
e. Observar evolución

Respuesta correcta: e. Observar evolución

Explicación: El trazado muestra un bloqueo aurículo-ventricular de 2º grado (se ve una onda P que no conduce), de tipo Mobitz I (el PR se va alargando progresivamente hasta que la onda P no conduce y luego vuelve a ser corto). Por tanto, si está asintomático, se observa. Recordar que solo reciben marcapasos definitivo 1. Los casos sintomáticos, 2. El BAV de 3º grado (o completo), 3. El BAV de 2º grado Mobitz II y 4. el bloqueo trifascicular (los dos últimos por el alto riesgo de evolución a de tercer grado). - Recordar que en los casos de bradicardia con hemodinamia inestable, se debe instalar un marcapasos externo transitorio, aunque es correcto iniciar con atropina endovenosa antes. - En el manejo definitivo, se se identifica una causa reversible y se logra tratar, se puede evitar el uso de marcapasos definitivo.

Fuente: Cardiología, cuestionario 10.2, P17

69. Un paciente hipertenso, asintomático se realiza un electrocardiograma, como parte de su chequeo habitual, constatándose el siguiente trazado: La conducta más adecuada es:



a. Observar evolución

b. Solicitar un Holter de arritmias
c. Derivar para marcapasos definitivo
d. Iniciar propanolol
e. Iniciar amiodarona

Respuesta correcta: a. Observar evolución

Explicación: Tiene un BAV de segundo grado, Mobitz I (El segmento PR se alarga, hasta que no conduce una onda P). Se observa, al igual que el BAV de primer grado (alargamiento del PR, pero toda onda P conduce). Solo si es sintomático (síncopes), requiere marcapasos. En cambio, el Mobitz II (PR constante y algunas ondas P no conducen) y el de tercer grado (disociación AV), sí se tratan con marcapasos.

Fuente: Cardiología, cuestionario 10.4, P9

70. La hipercalcemia en el electrocardiograma suele presentar:

a. Ondas T picudas
b. Ondas T invertidas
c. Supradesnivel del segmento ST
d. Acortamiento del intervalo QT
e. Alargamiento del intervalo QT

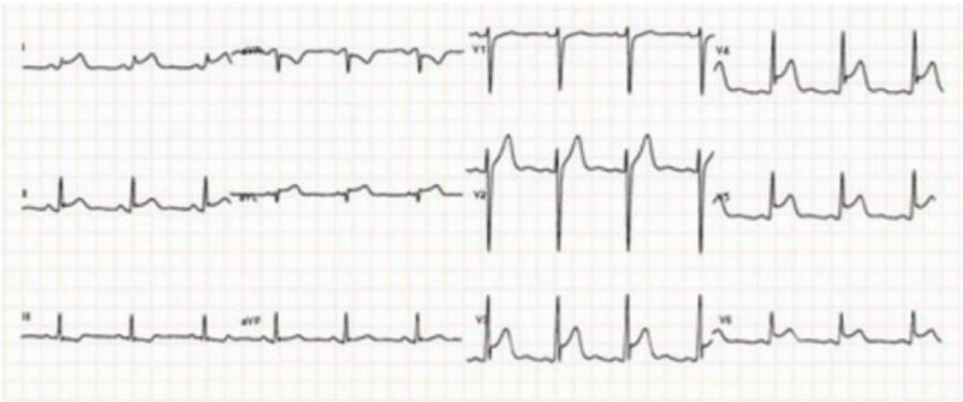
Respuesta correcta: d. Acortamiento del intervalo QT

Explicación: Las ondas T picudas son de la hiperkalemia. Las ondas T invertidas son características de isquemia (también en MCP HT). El SDST se ve en los IAM transmurales y en la pericarditis aguda. También en los aneurismas ventriculares (en que es persistente el SDST). El acortamiento del QT se ve en la hipercalcemia y en la intoxicación con digitálicos. El alargamiento del QT se ve en la hipocalcemia, hipokalemia e hipomagnesemia y se asocia a torsión de puntas.

Fuente: Cardiología, cuestionario 10.4, P15

Pericarditis y taponamiento cardíaco (3)

71. Una paciente de 30 años consulta por dolor torácico intenso, que aumenta con la inspiración y que disminuye al adoptar una posición genupectoral. Se solicita un electrocardiograma que muestra elevación del segmento ST en V1 a V6. La creatininfosfoquinasa Mb es normal. La conducta más adecuada es:



a. Iniciar ibuprofeno oral
b. Iniciar aspirina, oxígeno, nitroglicerina y realizar trombólisis con estreptoquinasa
c. Anticoagular con heparina y realizar coronariografía de urgencia

d. Hospitalizar y solicitar angioTAC de tórax
e. Solicitar dímero D

Respuesta correcta: a. Iniciar ibuprofeno oral

Explicación: Es una pericarditis aguda clásica (paciente joven con dolor torácico, que aumenta con la inspiración y con supradesnivel del ST difuso en las precordiales) que se trata con ibuprofeno o con otro AINE en dosis altas por vía oral. La B hubiese sido la correcta, si hubiese sido un síndrome coronario agudo (con factores de riesgo y clínica sugerente, que no aumente con la inspiración). La D hubiese sido la correcta si en el electrocardiograma hubiese salido el patrón S1Q3T3, por sospecha de TEP. El dímero D no está indicado a menos que haya una baja sospecha de TEP.

Fuente: Cardiología, cuestionario 10.1, P5 · Cardiología, cuestionario 10.5, P6

72. Un paciente de 25 años consulta por dolor torácico, que aumenta con la inspiración y que cede al inclinarse hacia adelante, por lo que adopta la posición genupectoral. Se solicita un electrocardiograma, que muestra supradesnivel del segmento ST en "j" en todas las derivaciones precordiales. ¿Qué fármaco es más adecuado para el tratamiento de este paciente?

a. Prednisona
b. Ibuprofeno
c. Aciclovir
d. Estreptokinasa
e. Heparina

Respuesta correcta: b. Ibuprofeno

Explicación: Es una pericarditis aguda clásica, tanto por la clínica (paciente joven con dolor torácico que aumenta con la inspiración y disminuye al inclinarse hacia adelante), como por el EKG (SDST "en J"). Por tanto se trata con AINES en dosis altas.

Fuente: Cardiología, cuestionario 10.2, P16

73. Un paciente sufre una herida con arma blanca en el pecho, evolucionando con hipotensión e ingurgitación yugular. La conducta inicial más adecuada es:

a. Realizar compresiones torácicas
b. Administrar suero fisiológico
c. Realizar pericardiocentesis
d. Instalar un catéter venoso central
e. Solicitar radiografía de tórax

Respuesta correcta: c. Realizar pericardiocentesis

Explicación: Tiene una clínica de taponamiento cardíaco agudo, por hemopericardio (herida penetrante, seguida de hipotensión e ingurgitación yugular, sin compromiso pulmonar). Por tanto, se debe realizar la pericardiocentesis de manera urgente. - Si hubiese tenido clínica pulmonar (desviación de la tráquea, asimetría torácica, etc.), la sospecha habría sido un neumotórax a tensión y la conducta sería puncionar el segundo espacio intercostal en la línea medioclavicular (o el quinto espacio en la línea axilar anterior). - Si hubiese estado bien, sin complicaciones, la conducta hubiese sido la radiografía de tórax, ya que esa es la forma en que se estudian las heridas por arma blanca, sin signos de alarma en el tórax. En el abdomen, en cambio, es con la exploración digital; o con laparotomía si es que están hemodinámicamente inestables o tienen signos peritoneales). Estos detalles se verán en cirugía.

Fuente: Cardiología, cuestionario 10.4, P18

Endocarditis infecciosa (3)

74. ¿Cuál de las siguientes es una indicación de cirugía en un paciente cursando una endocarditis bacteriana aguda?

a. Hemocultivo positivo para Staphilococcus aureus meticilino resistente
b. Ecocardiograma con un absceso perivalvular
c. Presencia de petequias en el examen físico
d. Antecedente de estenosis mitral
e. Antecedente de cardiopatía congénita cianótica operada

Respuesta correcta: b. Ecocardiograma con un absceso perivalvular

Explicación: Los 1. abscesos perivalvulares, junto con 2. la insuficiencia valvular severa o con falla cardíaca asociada, 3. la falta de respuesta a tratamiento, 4. la endocarditis por hongos (porque suele tener mala respuesta) y 5. las embolias a repetición o con vegetaciones muy grandes, son indicaciones de cirugía. - La alternativa A es indicación de utilizar vancomicina, aunque actualmente también se recomienda en casos en que no se ha aislado una bacteria aún o no se conoce su perfil de seguridad. - Las alternativas C,D y E son elementos que hacen pensar en endocarditis, pero no son indicaciones de cirugía.

Fuente: Cardiología, cuestionario 10.1, P12

75. ¿Cuál de las siguientes es una indicación de cirugía en un paciente cursando una endocarditis bacteriana aguda?

a. Hemocultivo positivo para Staphilococcus aureus meticilino resistente
b. Ecocardiograma con rotura de velo mitral anterior e insuficiencia valvular
c. Presencia de petequias en el examen físico
d. Antecedente de estenosis mitral
e. Antecedente de cardiopatía congénita cianótica operada

Respuesta correcta: b. Ecocardiograma con rotura de velo mitral anterior e insuficiencia valvular

Explicación: Son indicación de cirugía: 1. Abscesos, 2. ICC severa por insuficiencia valvular (es lo más frecuente y es muy común que ocurra en las endocarditis infecciosas agudas por S. aureus); 3. Embolias a repetición o vegetaciones muy grandes, con alto riesgo; 4. Falla de respuesta al tratamiento médico; 5. EBSA por hongos (suele fallar el tratamiento médico).

Fuente: Cardiología, cuestionario 10.2, P8

76. ¿Cuál es el agente etiológico más frecuente de la endocarditis bacteriana subaguda, de 10 días de evolución, en un paciente sin factores de riesgo conocidos ni hospitalizaciones recientes?

a. Streptococcus pyogenes
b. Streptococcus viridans
c. Staphilococcus epidermidis
d. Entorococcus faecium
e. Kingella Kingae

Respuesta correcta: b. Streptococcus viridans

Explicación: El agente de la EBSA (mayor a 7 días) es el Streptococcus viridans, seguido del Enterococo. - En la endocarditis aguda (menor a 7 días), lo más frecuente es el Staphilococcus aureus, en especial, si está asociado a algún catéter o invasión. Además, el S. aureus es la principal causa de endocarditis infecciosa, tomando en cuenta tanto las agudas como las subagudas. De hecho, actualmente, se ha

tendido a borrar la diferencia entre "agudas" y "subagudas", ya que la gran mayoría son agudas y a que la microbiología queda demostrada en el mismo hemocultivo que se usa para el diagnóstico. Por tanto, el tratamiento suele ser dirigido a la bacteria que se identifica. En los casos en que no se identifica una bacteria, actualmente se recomienda cubrir siempre SAMR, además de las demás bacterias mencionadas. Lo mismo si es que se identifica un S. aureus y aún no se tiene el antibiograma. - El Staphilococcus epidermidis es causa de la sepsis asociada a catéter, en la que la infección está solo en el catéter y no en el corazón. Sin embargo, también es la cuarta causa de endocarditis.

Fuente: Cardiología, cuestionario 10.4, P13

Tromboembolismo pulmonar y trombosis venosa (6)

77. Una paciente puérpera de 24 horas, cuyo parto fue por cesárea, presenta disnea de manera súbita, la que se acompaña de dolor torácico que le impide respirar profundamente. El examen físico muestra taquipnea de 35x', sin otras alteraciones. La conducta más adecuada es:

a. Solicitar radiografía de tórax
b. Solicitar angioTAC de tórax
c. Solicitar ecocardiograma transesofágico
d. Solicitar dímero
e. Solicitar electrocardiograma

Respuesta correcta: b. Solicitar angioTAC de tórax

Explicación: Tiene una clínica de TEP (disnea y dolor torácico súbito, que aumenta con la inspiración, con antecedentes de puerperio y cesárea). Dado que es de alta probabilidad, la respuesta correcta es el angioTAC de tórax. Si hubiese sido una paciente con la misma clínica, sin ningún factor de riesgo, es decir baja probabilidad de TEP, la respuesta correcta hubiese sido el dímero D. En este caso el dímero D no sirve tanto porque hay alta sospecha como porque la misma cesárea y puerperio lo elevan.

Fuente: Cardiología, cuestionario 10.1, P6

78. Una paciente 25 años, usuaria de anticonceptivos orales, presenta disnea de manera súbita, la que se acompaña de dolor torácico que le impide respirar profundamente. Está muy asustada y la familia comenta que ha estado muy estresada y angustiada en el último tiempo. El examen físico muestra una paciente en buenas condiciones generales, con taquipnea de 30x', con frecuencia cardíaca 85x' y presión arterial 120/70 mmHg, saturando 98% a FiO2 ambiental. Su examen cardiopulmonar no tiene otras alteraciones. La conducta más adecuada es:

a. Solicitar radiografía de tórax
b. Solicitar angioTAC de tórax
c. Solicitar ecocardiograma transesofágico
d. Solicitar dímero D
e. Solicitar electrocardiograma

Respuesta correcta: d. Solicitar dímero D

Explicación: Es una pregunta discutible. Sin embargo, el cuadro es sugerente de un TEP (disena súbita y dolor torácico que aumenta con la inspiración, más taquipnea). Sin embargo, es una paciente joven y de bajo riesgo (solo usa ACO, que aumentan el riesgo de TEP, pero solo levemente) y perfectamente puede ser una crisis de pánico. El dímero D es una buena forma de iniciar es estudio en pacientes de bajo riesgo de TEP y si está negativo, se descarta el TEP. En cambio, si está positivo, se debe confirmar con un

angioTAC. SI hubiese tenido algún factor de riesgo adicional o clínica más sugerente (ej. Hemoptisis), la respuesta sin duda habría sido el angioTAC de tórax, que es el examen de elección.

Fuente: Cardiología, cuestionario 10.2, P2

79. Un paciente de 46 años presenta aumento de volumen y dolor de la pierna izquierda, de 3 días de evolución. Presenta súbitamente dolor torácico, con tope inspiratorio, asociado a disnea. ¿Qué examen es más adecuado para proseguir con el estudio de este paciente?

a. Radiografía de tórax
b. Dímero D
c. AngioTAC de tórax
d. Angiografía pulmonar
e. Ecocardiograma

Respuesta correcta: c. AngioTAC de tórax

Explicación: La sospecha es un TEP y en este caso es de alto riesgo o alta probabilidad, ya que estuvo precedido por una clínica muy sugerente de TVP. Por tanto se pide el examen confirmatorio, que es el AngioTAC de tórax. - Si hubiese estado hipotenso y no respondiera a volumen, habría sido un TEP masivo y la respuesta sería el ecocardiograma (en busca de hipertensión pulmonar). - Si hubiese tenido clínica de neumotórax (disminución del MP, hipersonoridad), la respuesta habría sido radiografía de tórax.

Fuente: Cardiología, cuestionario 10.2, P18

80. Un paciente presenta dolor en la pierna izquierda, asociada a aumento de volumen. Dos días después presenta súbitamente disnea y dolor torácico tipo puntada. La conducta más adecuada es:

a. Solicitar radiografía de tórax
b. Solicitar ecocardiografía transesofágica
c. Solicitar dímero D
d. Solicitar angioTAC
e. Iniciar aspirina

Respuesta correcta: d. Solicitar angioTAC

Explicación: La sospecha es un TEP y en este caso es de alto riesgo o alta probabilidad, ya que estuvo precedido por una clínica muy sugerente de TVP. Por tanto se pide el examen confirmatorio, que es el AngioTAC de tórax. Si hubiese sido de baja probabilidad (ej. Sospecha de crisis de pánico), se debería pedir un dímero D. Si hubiese estado hipotenso, habría sido un TEP masivo y la respuesta sería el ecocardiograma. Si hubiese tenido clínica de neumotórax (disminución del MP, hipersonoridad), la respuesta habría sido radiografía de tórax. Si no hubiese estado disponible el angioTAC, se debe anticoagular de inmediato y dar soporte. Además, si está disponible el eco-Doppler de EEII y se confirma la TVP, se da por confirmado el TEP, a pesar de no contar con un angioTAC (si está disponible se debe pedir).

Fuente: Cardiología, cuestionario 10.4, P6

81. Un paciente de 46 años presenta aumento de volumen y dolor de la pierna izquierda, de 3 días de evolución. Presenta súbitamente dolor torácico, con tope inspiratorio, asociado a disnea, confusión y presiones arteriales de 60/40 mmHg, que no mejoran luego de administrar 1.500 cc de suero fisiológico. ¿Qué examen es más adecuado para proseguir con el estudio de este paciente?

a. Radiografía de tórax
b. Dímero D

c. AngioTAC de tórax
d. AngioRMN de tórax
e. Ecocardiograma

Respuesta correcta: e. Ecocardiograma

Explicación: La clínica es muy sugerente de un TEP masivo, ya que tiene el antecedente de clínica de TVP y evoluciona con una clínica compatible con un TEP, pero con hemodinamia inestable que no responde a volumen, lo que lo vuelve masivo. El TEP masivo se estudia con ecocardiografía y se trata con trombólisis urgente. La ecocardiografía muestra hipertensión pulmonar (presión arteria pulmonar mayor a 25 mmHg), con lo que se confirma el diagnóstico y se pasa directamente a la trombólisis. Actualmente no se utiliza casi la angiografía pulmonar. En cambio, el TEP no masivo se estudia con angioTAC de tórax y se trata con anticoagulación (heparina y luego TACO por al menos 6 meses).

Fuente: Cardiología, cuestionario 10.5, P18

82. Un paciente de 65 años presenta dolor abdominal epigástrico de 3 meses de evolución y, desde hace 1 mes, presenta ictericia y orinas más oscuras. No había querido consultar previamente, pero el día de hoy presenta dolor torácico y disnea, por lo que consulta en el servicio de urgencia. Al examen físico tiene ictericia de piel y escleras, FC: 115x', PA: 120/80 mmHg, FR: 23x', SatO2: 90%, auscultación cardíaca RR2T sin soplos y auscultación pulmonar normal. El examen abdominal solo muestra dolor a la palpación epigástrica, sin signos peritoneales. La radiografía de tórax es normal y el EKG muestra ritmo sinusal con frecuencia de 116x'. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

a. Solicitar un ecocardiograma
b. Solicitar espirometría
c. Solicitar angioTAC de tórax urgencia y administrar oxígeno
d. Solicitar TAC abdominal y derivar a especialista
e. Iniciar aspirina, oxígeno, nitroglicerina y solicitar troponinas, controlando con EKG seriados

Respuesta correcta: c. Solicitar angioTAC de tórax urgencia y administrar oxígeno

Explicación: Pregunta difícil, pero importante aprender a enfrentarla: tiene un TEP y, de base, tiene un probable cáncer de páncreas o de otro tipo (ictericia silente), que también debe ser manejado, pero después de descartado y manejado el TEP. Orientan al TEP la clínica respiratoria de un día de evolución, con la desaturación arterial, taquipnea y taquicardia sinusal.

Fuente: Cardiología, cuestionario 10.6, P3

Patología aórtica y arterial periférica (12)

83. Una paciente de 70 años consulta por dolor torácico muy intenso, de inicio súbito. Al examen físico se constata abolición de los pulsos de las extremidades inferiores. El diagnóstico más probable es:

a. Infarto agudo al miocardio, con rotura de músculo papilar
b. Infarto agudo al miocardio, en paciente con estenosis aórtica
c. Infarto agudo al miocardio, con formación de aneurisma ventricular
d. Tromboembolismo pulmonar
e. Disección aórtica

Respuesta correcta: e. Disección aórtica

Explicación: El dolor torácico más la abolición de los pulsos sugiere fuertemente disección aórtica y se debe pedir un Angiotac de tórax urgente. - El infarto agudo del miocardio con rotura de musculo papilar,

vendría con clínica de infarto de más de 24 horas, más soplo holosistólico. - El infarto agudo de miocardio, con estenosis aórtica, tendría el soplo eyectivo y clínica de estenosis aórtica. - En el infarto agudo al miocardio, con formación de aneurismas ventricular, tendría fenómenos embólicos mucho tiempo después y supradesnivel del ST persistente en electrocardiograma. - El TEP tendría el dolor torácico que aumenta con la inspiración, trombofilia, desaturación arterial etc.

Fuente: Cardiología, cuestionario 10.1, P15

84. Un paciente presenta de manera súbita dolor de la pierna y pie derechos, asociado a parestesias. Al examen físico se aprecia palidez de la pierna y el pie, con ausencia de pulsos pedio y tibial posterior. La conducta inicial más importante es:

a. Anticoagular con heparina
b. Solicitar ecografía doppler de EEII
c. Solicitar PVR (pletismografía de volumen) de EEII
d. Administrar aspirina 500 mg a masticar
e. Indicar reposo con la extremidad inferior derecha levantada

Respuesta correcta: a. Anticoagular con heparina

Explicación: Es una isquemia aguda de extremidades inferiores (6P: pain o dolor, parestesias, palidez, pulso ausente) el diagnóstico es clínico y la conducta es anticoagular con heparina y revascularizar con urgencia. - La heparina se da como un bolo y luego goteo. - La revascularización se suele hacer con embolectomía abierta o endovascular con catéter. En casos seleccionados, se puede realizar trombólisis. - Generalmente se realiza una angiografía para guiar el procedimiento de embolectomía. También se puede hacer un angioTAC, pero lo importante es que no demore la revascularización, ya que el diagnóstico es clínico. La alternativa B, sería correcta ante una clínica de TVP (dolor, eritema, edema). La alternativa C: PVR, sería aceptable en el caso de una isquemia crónica, aunque actualmente lo más importante para una isquemia crónica es la clínica (se vuelve crítica cuando tiene úlceras isquémicas, dolor de reposo o índice tobillo brazo menor a 0,4). Por tanto, la PVR no necesariamente debe ser solicitada en la actualidad. PVR significa "registro de volumen de pulso". La alternativa E (reposo en elevación) sería correcta en una úlcera venosa.

Fuente: Cardiología, cuestionario 10.1, P18

85. Una paciente de 65 años, con antecedente de fibrilación auricular, hipertensión arterial y diabetes, en tratamiento con rivaroxabán, amiodarona, enalapril, atenolol, metformina y liraglutide consulta, porque, desde hace 1 horas presenta dolor de la pierna y pie izquierdos, asociado a parestesias. Al examen físico se aprecia pierna y el pie, con ausencia de pulsos y con llene capilar muy enlentecido. Se anticoagula con heparina. La conducta más adecuada es:

a. Realizar embolectomía quirúrgica
b. Solicitar ecografía doppler de EEII
c. Solicitar pruebas de coagulación y niveles plasmáticos de factor X activado
d. Administrar aspirina y clopidogrel
e. Solicitar angioTAC de tórax de urgencia

Respuesta correcta: a. Realizar embolectomía quirúrgica

Explicación: Es una isquemia aguda de extremidades inferiores (6P: pain o dolor, parestesias, palidez, pulso ausente), causada por una embolia, en contexto de la fibrilación auricular, a pesar de estar anticoagulado. En este momento está en ritmo sinusal, pero ello no descarta que haya estado previamente en fibrilación auricular. El diagnóstico de la isquemia aguda es clínico y la conducta es

anticoagular con heparina, además de realizar revascularización inmediata (ej. con embolectomía quirúrgica abierta o endovascular, o en casos seleccionados, con trombólisis intra arterial. Se realiza una angiografía durante el procedimiento de revascularización. Es aceptable hacer un angioTAC previo, en la medida que no retrase la revascularización.

Fuente: Cardiología, cuestionario 10.2, P10

86. Un paciente de 60 años presenta dolor torácico de 30 minutos de evolución, muy intenso, irradiado a la espalda. Al examen físico presenta PA: 220/130, FC: 100x' y se auscultan crepitaciones pulmonares. Además, tiene disminución de los pulsos pedios, con normalidad de los pulsos radiales. ¿Cuál de los siguientes fármacos debe administrarse en primer lugar?

a. Propanolol
b. Noradrenalina
c. Ácido acetilsalicílico
d. Estreptokinasa
e. Nitroprusiato

Respuesta correcta: e. Nitroprusiato

Explicación: Esta pregunta puede ser enfrentada de 2 formas. La primera es sospechar una disección aórtica (dolor torácico intenso, asociado a PA muy elevada y asimetría de pulsos), la que se debe manejar con antihipertensivos endovenosos, como el labetalol o el nitroprusiato. La segunda forma es diagnosticar una crisis hipertensiva, con probable compromiso de órganos y riesgo vital (por la probable disección), la que debe manejarse igualmente con fármacos antihipertensivos endovenosos. * Además, se debe solicitar un angioTAC de tórax, por sospecha de una disección aórtica. Eventualmente requerirá cirugía vascular urgente.

Fuente: Cardiología, cuestionario 10.2, P15

87. Un paciente de 69 años, hipertenso, consulta por dolor torácico muy intenso, de 1 hora de evolución, que ha ido en aumento. Al examen físico se aprecia hipertenso, con PA: 200/120 mmHg, FC: 110 x´, sudoroso y se ausculta un MP(+) con crépitos bibasales y RR2T con soplo diastólico. El electrocardiograma muestra una taquicardia sinusal, sin alteraciones del segmento ST. La conducta más adecuada es:

a. Solicitar angioTAC de tórax
b. Solicitar angiografía de urgencia
c. Iniciar anticoagulación con heparina
d. Administrar aspirina, oxígeno y nitroglicerina y solicitar troponinas plasmáticas seriadas
e. Administrar aspirina, oxígeno y nitroglicerina y realizar trombolisis con estreptoquinasa

Respuesta correcta: a. Solicitar angioTAC de tórax

Explicación: La clínica es muy sugerente de una disección aórtica. Tiene el dolor torácico, está en una crisis hipertensiva y además tiene el soplo diastólico característico de la insuficiencia aórtica (porque la válvula aórtica se diseca). Con ello ya es suficiente para realizar el angioTAC de tórax. Que el EKG no muestre signos de isquemia, con mayor razón hace pensar en una disección aórtica. Además del angioTAC, sería correcto darle antihipertensivos por vía endovenosa (labetalol y/o nitroprusiato) y llamar al cirujano cardiovascular de manera urgente, ya que todo apunta a una disección tipo A (el soplo sugiere que se afecta la raíz aórtica), la que requiere reemplazo de la aorta. - La alternativa D habría sido correcta si la clínica no hubiese tenido el soplo y hubiese tenido más elementos de síndrome coronario agudo (en este caso sin SDST). - La alternativa E hubiese sido correcta si el EKG hubiese mostrado un SDST y no

hubiese habido soplo diastólico. - Los antiagregantes, la anticoagulación y la trombólisis están absolutamente contraindicadas, ya que pueden agravar la hemorragia.

Fuente: Cardiología, cuestionario 10.3, P5

88. Un paciente de 69 años consulta por dolor abdominal intenso, que ha ido en aumento. Al examen físico está pálido e hipotenso y se palpa una masa pulsátil en el epigastrio, que no se mueve con la inspiración. El diagnóstico más probable es:

a. Disección aórtica tipo A
b. Disección aórtica tipo B
c. Aneurisma aórtico abdominal roto
d. Infarto miocárdico de pared inferior
e. Embolia mesentérica

Respuesta correcta: c. Aneurisma aórtico abdominal roto

Explicación: Es un aneurismoa aórtico abdominal roto clásico (AAA roto). Tiene el dolor, el shock hipovolémico y la masa pulsátil. El hecho que no se mueva con la inspiración, da cuenta que está localizado en el retroperitoneo (tanto la aorta, como el hematoma que se forma al romperse el auneurisma suelen ser retroperitoneales). La otra forma de presentación clásica es igual a un cólico renal, pero con compromiso hemodinámico, en un paciente generalmente con factores de riesgo cardiovascular, ya que su etiología principal es la ateromatosis.

Fuente: Cardiología, cuestionario 10.4, P8

89. Un paciente diabético, dislipidémico y fumador, en tratamiento con glibenclamida, metformina, y atorvastatina, consulta por dolor en las pantorrillas, mayor en la pierna derecha, que aparece al caminar 3 cuadras y que le impide seguir caminando. Su examen físico es normal. Además de suspender el cigarrillo y optimizar el control de sus factores de riesgo cardiovascular, se debe:

a. Solicitar angiografía de extremidades inferiores
b. Solicitar resonancia magnética de columna
c. Solicitar ecografía Doppler de extremidades inferiores
d. Iniciar anticoagulación a permanencia
e. Indicar ejercicios de caminata e iniciar aspirina

Respuesta correcta: e. Indicar ejercicios de caminata e iniciar aspirina

Explicación: Tiene clínica de una claudicación intermitente, sin signos de isquemia crítica (no hay dolor de reposo, ni úlceras arteriales ni un índice tobillo brazo menor a 0,5). Por tanto, se deben manejar los FR CV e iniciar un programa de ejercicios. El diagnóstico es clínico y la mejor forma de objetivar la severidad es con pruebas no invasivas, en especial, el índice tobillo brazo (ITB) que simplemente compara las presiones arteriales del tobillo y brazo: - Si el ITB es mayor a 1, es normal. - Entre 0,9 y 0,5 es compatible con claudicación intermitente. - Entre 0,4 y valores menores es compatible con isquemia crítica (que requiere vascularización. También son útiles los registros de volumen de pulso, como la pletismografía de volumen, que si bien suelen usarse mucho en la isquemia crítica, también dan información útil en la isquemia no crítica, como en este caso. * La angiografía sería correcta para una isquemia aguda de EEII (dolor súbito, con palidez y frialdad, disminución de pulsos, paresisay parestesias). Además, se anticoagula y se revasculariza con urgencia. * La RMN de columna sería correcta para una raquiestenosis (dolor lumbar irradiado a las EEII, que aumenta al caminar, en adultomayor). * La ecografía Doppler de EEII sirve en la trombosis venosa profunda (TVP).

Fuente: Cardiología, cuestionario 10.4, P19

90. Una paciente de 70 años consulta por dolor torácico muy intenso, de inicio súbito. Al examen físico se constata abolición de los pulsos de las extremidades inferiores. El diagnóstico más probable es:

a. Infarto agudo al miocardio, con rotura de músculo papilar
b. Infarto agudo al miocardio, en paciente con estenosis aórtica
c. Infarto agudo al miocardio, con formación de aneurisma ventricular
d. Tromboembolismo pumonar
e. Disección aórtica

Respuesta correcta: e. Disección aórtica

Explicación: La abolición de los pulsos de las EEII es muy sugerente de una disección aórtica, ya que el flap de disección produce obstrucción de la aorta y sus ramas. La rotura de músculo papilar tendría un soplo holosistólico y acontecería algunos días después del IAM. La estenosis aórtica tendría soplo sistólico, R2 disminuido, antecedente de ICC, angina y síncopes. El aneurisma ventricular se presenta como embolias a repetición, después de un IAM, con SDST persistente en el EKG. El TEP es un dolor de inicio agudo, que aumenta con la inspiración, con antecedente de trombofilias y que se asocia a fiebre, hemoptisis, desaturación arterial y disnea.

Fuente: Cardiología, cuestionario 10.5, P9

91. Un paciente de 70 años presenta dolor torácico de 1 hora de evolución, con intensidad 10/10, asociado a sensación de muerte inminente. Al examen físico está taquicárdico e hipertenso y se constata la presencia de un soplo diastólico intenso. Se solicita un electrocardiograma, que muestra alteraciones inespecíficas del segmento ST. La conducta inicial más adecuada es:

a. Administrar aspirina
b. Solicitar angioTAC
c. Realizar trombolisis
d. Solicitar coronariografía
e. Asministrar heparina

Respuesta correcta: b. Solicitar angioTAC

Explicación: El soplo diastólico intenso, es característico de la disección aórtica, porque el flap de disección rompe la válvula aórtica. Que no haya signos de isquemia en el EKG hace muy improbable un IAM. Dada la sospecha de disección, se debe pedir un angioTAC de tórax. Una vez confirmada, se manejará con cirugía urgente, al tratarse de una disección tipo A (al afectar la raíz aórtica y la válvula aórtica). Si estuviera hipertenso, también requeriría antihipertensivos por vía endovenosa (labetalol y/o nitroprusiato). La A, C y E están absolutamente contraindicadas (agravan la hemorragia y pueden matar al paciente).

Fuente: Cardiología, cuestionario 10.5, P12

92. Un paciente fumador, de 68 años, consulta por dolor en la pantorrilla derecha, que aparece al caminar 2 cuadras y que le obliga a detenerse, cediendo con el reposo. No presenta otros síntomas y el examen físico no aporta mayor información, salvo un índice tobillo brazo (ITB) de 0,8. Sus exámenes generales son normales. La conducta más adecuada es:

a. Suspender el cigarrillo solicitar angiografía de extremidad inferior
b. Suspender el cigarrillo, iniciar aspirina e indicar un programa de ejercicios
c. Suspender el cigarrillo, administrar heparina y solicitar angioTAC de EEII
d. Suspender el cigarrillo e iniciar anticoagulación con cumarínicos

e. Suspender el cigarrillo y resolver quirúrgicamente

Respuesta correcta: b. Suspender el cigarrillo, iniciar aspirina e indicar un programa de ejercicios

Explicación: Es una claudicación intermitente, sin signos de isquemia crítica (índice tobillo/brazo menor a 0,5, úlcera arterial o dolor de reposo). Por tanto, debe ser manejada con control de sus factores de riesgo cardiovascular, más un programa de ejercicios, que le permita mejorar su tolerancia al ejercicio (induce la formación de colaterales). * Actualmente la prueba más importante en la enfermedad arterial periférica es el simple índice tobillo brazo, que si está menor a 0,9 confirma el diagnóstico de enfermedad arterial periférica y, si es de 0,4 o menos, es compatible con isquemia crítica, que requiere revascularización. * Los registros de volumen de pulso (PVR), como la pletismografía todavía se pueden usar y no es obligatorio usarlos solo en pacientes con isquemia crítica, ya que también entregan información útil en pacientes con isquemia no crítica, como en este caso. * Por regla general no es necesario realizar una angiografía o un angioTAC en la isquemia crónica, salvo que ya se haya decidido que se resolverá con revascularización quirúrgica, ya que sirve para determinar algunos aspectos prácticos de la cirugía. En cambio, en la isquemia aguda suelen ser muy útiles (a pesar de que la clínica y la revascularización urgente siguen siendo lo más importante). - La heparina y la angiografía serían correctas en una embolia de extremidades inferiores (las 6P). - La ecografía Doppler de EEII es correcta en la TVP.

Fuente: Cardiología, cuestionario 10.5, P16

93. Una paciente de 60 años acude al servicio de urgencia por dolor intenso en la extremidad inferior derecha, que inició hace menos de 1 hora, asociado a imposibilidad de mover los ortejos. Al examen físico se observa pierna y pie derechos pálidos y fríos, con ausencia de pulsos pedios y tibiales. La conducta inicial más adecuada es:

a. Administrar estreptoquinasa endovenosa
b. Solicitar pletismografía de volumen de la extremidad
c. Indicar reposo con la pierna en alto y administrar analgésicos
d. Solicitar ecografía doppler de extremidades inferiores
e. Anticoagular con heparina de inmediato y solicitar angioTAC de la extremidad y evaluación por cirujano vascular, de manera urgente

Respuesta correcta: e. Anticoagular con heparina de inmediato y solicitar angioTAC de la extremidad y evaluación por cirujano vascular, de manera urgente

Explicación: Tiene una isquemia aguda de extremidades inferiores, cuyo diagnóstico es clínico y su manejo consiste en la revascularización inmediata. La primera medida es la anticoagulaicón, generalmente con heparina no fraccionada. El estudio se puede hacer con angioTAC o con angiografía mediante catéter intraarterial, de manera de identificar la zona de obstrucción. La revascularización se puede realizar con trombólisis intrarterial o con embolectomía transcatéter o abierta. También se debe buscar activamente la fuente embólica y tratarla (ej. pedir ecocardiografía).

Fuente: Cardiología, cuestionario 10.6, P8

94. Un paciente de 70 años, hipertenso, se realiza una ecografía abdominal, como parte de un cuadro de constipación, que muestra un aneurisma de la aorta abdominal de 7 cm de diámetro. No ha presentado dolor abdominal y el resto de su examen físico es normal. La conducta más adecuada es:

a. Derivar a cirugía vascular para resolución a la brevedad
b. Indicar uso de faja y controlar con ecografías periódicas
c. Iniciar anticoagulación con heparina y mejorar el control de sus factores de riesgo cardiovascular
d. Iniciar aspirina y mejorar el control de sus factores de riesgo cardiovascular

e. Asegurar un adecuado control de la presión arterial y de los otros factores de riesgo cardiovascular y observar evolución

Respuesta correcta: a. Derivar a cirugía vascular para resolución a la brevedad

Explicación: Los aneurismas de la aorta abdominal mayores a 5 cm son de resolución quirúrgica.

Fuente: Cardiología, cuestionario 10.6, P11

Paro cardiorrespiratorio y shock (5)

95. Un paciente sufre un infarto miocárdico, evolucionando con compromiso de conciencia una hora después. Usted lo atiende 15 minutos después y constata que no tiene pulso y que no respira. Se inicia masaje cardíaco y se instala un monitor electrocardiográfico, con capacidad de desfibrilar. Cinco ciclos después, lo revalúa y constata que persiste sin pulso ni respiración y que el monitor es compatible con una actividad eléctrica sin pulso. La conducta más adecuada es:

a. Realizar desfibrilación eléctrica y continuar el masaje cardíaco
b. Administrar adrenalina endovenosa y continuar el masaje cardíaco
c. Administrar atropina endovenosa y continuar el masaje cardíaco
d. Continuar el masaje cardíaco
e. Suspender las maniobras de reanimación.

Respuesta correcta: b. Administrar adrenalina endovenosa y continuar el masaje cardíaco

Explicación: Es un paro cardio-respiratorio, en ritmo no desfibrilable (actividad eléctrica sin pulso) por lo cual se debe manejar con compresiones y adrenalina endovenosa. Si el paciente presentara un ritmo desfibrilable: fibrilación ventricular o taquicardia ventricular sin pulso, la respuesta correcta hubiese sido la A. Lleva sólo 5 ciclos, por lo cual no se deben suspender las maniobras de reanimación (se suspenden de luego de 20 a 30 minutos). Sí se debe continuar con masaje cardiaco, pero no es suficiente, por lo que la alternativa D sólo es correcta cuando no contamos con drogas ni desfibrilador.

Fuente: Cardiología, cuestionario 10.1, P10

96. Un paciente, cursando una neumonía neumocócica, con antecedente de insuficiencia cardíaca, evoluciona con franco deterioro del estado general. En su examen físico destaca PA: 70/30 mmHg y FC: 130 lpm. Se realiza monitorización invasiva, constatándose una marcada disminución de la resistencia vascular periférica. El diagnóstico más probable es:

a. Shock séptico
b. Shock hipovolémico
c. Shock cardiogénico
d. Shock anafiláctico
e. Shock medular

Respuesta correcta: a. Shock séptico

Explicación: La marcada disminución de la RVP (resistencia vascular periférica) es diagnóstica de un shock vasodilatador, que incluye al séptico, medular y anafiláctico. Tanto shock hipovolémico, como cardiogénico tienen elevada la RVP. Por la infección de base, lo más probable es que sea séptico. Si hubiese recibido un fármaco y evolucionado con urticaria y angioedema, sería anafiláctico. Asimismo, el antecedente de trauma medular sugiere shock medular. Vale la pena recordar que en contexto de una infección, lo más frecuente es que se trate de un shock hipovolémico, por lo que la primera medida es siempre dar el SF y solo si no responde, se asume que es séptico y se inicia la noradrenalina. Sin embargo,

en los casos en que está con un catéter de Swan Ganz, es posible medir la RVP, identificando de inmediato el shock vasodilatador.

Fuente: Cardiología, cuestionario 10.2, P13

97. Un paciente de 68 años, cursando una neumonía severa, presenta pérdida de conciencia. Al examen físico se constata ausencia de respiración y de pulso. Se inicia masaje cardíaco y ventilación con ambú y se instala monitor electrocardiográfico. Se reevalúa a los 2 minutos, persistiendo sin cambios y el monitor demuestra ritmo ventricular a 20x'. La conducta más adecuada es:

a. Proseguir con el masaje cardíaco y las ventilaciones con ambú, sin medidas adicionales
b. Realizar intubación orotraqueal y mantener el masaje y las ventilaciones
c. Realizar desfibrilación eléctrica y mantener el masaje y las ventilaciones
d. Administrar adrenalina endovenosa y proseguir con el masaje y las ventilaciones
e. Suspender las maniobras de resucitación

Respuesta correcta: d. Administrar adrenalina endovenosa y proseguir con el masaje y las ventilaciones

Explicación: Es un paro cardiorespiratorio, en actividad eléctrica sin pulso (AESP), es decir, un ritmo no desfibrilable, por lo que se debe manejar con las maniobras de RCP, más adrenalina ev 1 mg cada 3 a 5 minutos. Recordar que todos los ritmos distintos a la fibrilación ventricular, taquicardia ventricular y asistolia se consideran AESP, si es que están asociados a un paro. Las maniobras solo se suspenden después de 20 a 30 minutos de reanimación. La intubación se puede realizar, pero solo si es posible hacerlo, sin interferir con la reanimación, por lo tanto no es prioridad.

Fuente: Cardiología, cuestionario 10.2, P19

98. Un paciente presenta disnea de inicio súbito, seguida de compromiso de conciencia. Usted lo recibe 10 minutos después y está inconsciente, sin pulso ni respiración. Se inicia masaje cardíaco y se llama al equipo de reanimación, que cuenta con un desfibrilador. Luego de 5 ciclos de masaje, el paciente permanece en paro y el monitor electrocardiográfico muestra una taquicardia ventricular sin pulso. La conducta más adecuada es:

a. Administrar amiodarona endovenosa
b. Administrar adrenalina endovenosa y continuar el masaje cardíaco
c. Realizar desfibrilación eléctrica y continuar el masaje cardíaco
d. Realizar cardioversión eléctrica sincronizada y reevaluar de inmediato
e. Proseguir el masaje cardíaco e iniciar lidocaína por bomba de infusión

Respuesta correcta: c. Realizar desfibrilación eléctrica y continuar el masaje cardíaco

Explicación: Es un paciente en paro cardiorrespiratorio. Además está en TVSP, que es un ritmo desfibrilable, por lo que lo más correcto es desfibrilar y mantener el masaje. Si hubiese estado en un ritmo no desfibrilable (asistolia y AESP), lo más correcto sería la alternativa B (adrenalina y continuar el RCP). Si estuviese con pulso, es decir, si no estuviese en paro, pero con hemodinamia inestable, lo más correcto sería la cardioversión eléctrica. Si estuviese con pulso y hemodinamia estable, lo más correcto sería la amiodarona, como manejo de la TV con pulso. La amiodarona sí se usa en el manejo del paro en ritmos desfibrilables, pero luego de haber desfibrilado, seguido de haber desfibrilado más adrenalina y finalmente recién se debe desfibrilar más amiodarona o lidocaína.

Fuente: Cardiología, cuestionario 10.3, P8

99. Paciente de 78 años inicia dolor retroesternal seguido de pérdida de conciencia. Al examen paciente no responde, no respira y tiene pulso ausente. Se realizan maniobras de resucitación cardiopulmonar y se conecta al monitor cardíaco mostrando lo siguiente: ¿Cuál es la conducta más adecuada?

a. Finalizar con maniobras de RCP
b. Administrar adrenalina 1mg ev
c. Realizar desfibrilación eléctrica
d. Administrar amiodarona 300mg ev
e. Administrar lidocaína ev

Respuesta correcta: c. Realizar desfibrilación eléctrica

Explicación: Tiene un paro cardiorrespiratorio y el EKG muestra una taquicardia ventricular, por lo tanto tiene una TVSP (taquicardia ventricular sin pulso), lo que es un ritmo desfibrilable. Por eso, lo más adecuado es desfibrilar y proseguir con el masaje. Si no responde, en 2 minutos se vuelve a desfibrilar y se inicia la adrenalina ev. Si sigue sin responder, se vuelve a desfibrilar, se mantiene la adrenalina y se inicia la amiodarona.

Fuente: Cardiología, cuestionario 10.5, P5

Respiratorio (109)

Neumonía adquirida en la comunidad (12)

1. Un paciente de 35 años, presenta un cuadro compatible con una influenza, que evoluciona favorablemente, con tratamiento sintomático. Sin embargo, siete días después inicia un cuadro de tos, con expectoración mucopurulenta y fiebre alta, asociada a dificultad respiratoria y marcado compromiso del estado general. Se solicita una radiografía de tórax, que muestra zonas de relleno bilaterales e imágenes sugerentes de múltiples abscesos pulmonares. El agente etiológico más probable es:

a. Neumococo
b. Virus hanta
c. Anaerobios
d. Adenovirus
e. Estafilococo áureo

Respuesta propuesta: e. Estafilococo áureo

La prueba de origen no traía la respuesta ni la explicación; la alternativa indicada es una propuesta y no proviene del curso.

Fuente: Respiratorio, prueba 1 (captura), P2

2. Una paciente de 50 años, diagnosticada de fibrosis pulmonar consulta por fiebre y tos productiva. Al examen físico se encuentra en buenas condiciones, con pulso 87x' regular, presión arterial: 120/80 mmHg, frecuencia respiratoria: 17x', temperatura axilar: 38,5 °C y saturación arterial de oxígeno: 94%. Al examen pulmonar se auscultan crépitos bilaterales. Se solicita radiografía de tórax que muestra los cambios propios de la fibrosis pulmonar, asociados a una zona de relleno alveolar en el lóbulo inferior izquierdo, que no aparecía en las radiografías anteriores. La conducta más adecuada es:

a. Indicar amoxicilina oral
b. Iniciar amoxicilina más ácido clavulánico oral y controlar de forma ambulatoria
c. Hospitalizar e iniciar ceftriaxona endovenosa
d. Hospitalizar en UCI e iniciar una asociación entre un macrólido y una cefalosporina de tercera generación
e. Hospitalizar en UCI e iniciar una asociación entre una quinolona y una cefalosporina de tercera generación

Respuesta propuesta: b. Iniciar amoxicilina más ácido clavulánico oral y controlar de forma ambulatoria

La prueba de origen no traía la respuesta ni la explicación; la alternativa indicada es una propuesta y no proviene del curso.

Fuente: Respiratorio, prueba 1 (captura), P19

3. Un paciente de 70 años es diagnosticado de una neumonía del lóbulo inferior derecho, mediante una radiografía. Al examen físico está en buenas condiciones, satura 96% a FIO2 ambiental y sus signos vitales son normales. ¿Qué antibiótico es más adecuado para el tratamiento de este paciente?

a. Clindamicina
b. Ceftriaxona
c. Amoxicilina
d. Amoxicilina + ácido clavulánico
e. Azitromicina

Respuesta correcta: d. Amoxicilina + ácido clavulánico

Explicación: Es una neumonía adquirida en la comunidad, sin criterios de severidad, por lo que no requiere hospitalización. Se deben indicar antibióticos orales y por tener más de 65 años, de elección es la amoxicilina con ácido clavulánico (ya que cubre bien Haemophilus). La azitromicina también es una respuesta correcta, ya que cubre perfectamente todos los gérmenes, pero por regla general, la primera línea es la amoxicilina-clavulánico y los macrólidos solo se indican en pacientes alérgicos o con neumonías por atípicos (ej. Mycoplasma). Si hubiese tenido menos de 65 años, la respuesta hubiese sido amoxicilina. Si hubiese estado más grave, con indicación de hospitalización, habría sido correcta la ceftriaxona.

Fuente: Respiratorio, prueba 2 (captura), P2

4. Un paciente de 20 años, sin antecedentes de importancia, presenta un cuadro de 3 días de evolución de malestar general, asociado a fiebre, tos y expectoración mucopurulenta, al que luego se agregó disnea de pequeños esfuerzos. Al examen está vigil, con FC: 102 x', PA: 110/75 mmHg, FR: 33 rpm y saturación arterial 90% a FIO2 ambiental. Se solicita una radiografía de tórax, que muestra signos de condensación en los lóbulos medio e inferior derechos. Su hemograma muestra leucocitosis de 19.000 por mm3. ¿Qué antibiótico es más adecuado?

a. Amoxicilina
b. Claritromicina
c. Ceftriaxona
d. Amoxicilina + ácido clavulánico
e. Clindamicina

Respuesta propuesta: c. Ceftriaxona

La prueba de origen no traía la respuesta ni la explicación; la alternativa indicada es una propuesta y no proviene del curso.

Fuente: Respiratorio, prueba 3 (captura), P12

5. ¿Cuál de los siguientes es la mejor opción para un paciente alérgico a la penicilina, con una NAC de manejo ambulatorio?

a. Amoxicilina + ácido clavulánico
b. Azitromicina
c. Ceftriaxona
d. Clindamicina
e. Ampicilina + clorfenamina

Respuesta propuesta: b. Azitromicina

La prueba de origen no traía la respuesta ni la explicación; la alternativa indicada es una propuesta y no proviene del curso.

Fuente: Respiratorio, prueba 3 (captura), P17

6. Un paciente de 30 años presenta un cuadro de fiebre y tos con expectoración, asociado a malestar general intenso y disnea. Al examen físico está taquipneico con 35 rpm, satura 85% a FIO2 ambiental y se auscultan crepitaciones en la base pulmonar derecha. Se solicita una radiografía de tórax, que muestra una imagen de condensación de los lóbulos medio y superior derecho. El tratamiento más adecuado es:

a. Clindamicina
b. Ceftriaxona
c. Amoxicilina
d. Amoxicilina + ácido clavulánico
e. Moxifloxacino

Respuesta propuesta: b. Ceftriaxona

La prueba de origen no traía la respuesta ni la explicación; la alternativa indicada es una propuesta y no proviene del curso.

Fuente: Respiratorio, prueba 4 (captura), P20

7. Un paciente de 59 años, diagnosticado de fibrosis pulmonar, consulta por fiebre hasta 38,6 °C, asociado a malestar general y tos con expectoración mucopurulenta. Al examen físico se encuentra en buenas condiciones, satura 95% a FIO2 ambiental y tiene una frecuencia cardíaca de 90x'. El examen pulmonar muestra crepitaciones difusas, compatibles con su patología de base. Se solicita una radiografía de tórax que muestra imágenes compatibles con fibrosis pulmonar, asociadas a una zona de relleno alveolar en el lóbulo superior izquierdo. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

a. Indicar tratamiento ambulatorio con amoxicilina
b. Indicar tratamiento ambulatorio con amoxicilina más ácido clavulánico
c. Indicar tratamiento endovenoso con ceftriaxona
d. Indicar tratamiento endovenoso con ceftazidima más clindamicina
e. Indicar tratamiento endovenoso con ceftriaxona más metronidazol

Respuesta propuesta: b. Indicar tratamiento ambulatorio con amoxicilina más ácido clavulánico

La prueba de origen no traía la respuesta ni la explicación; la alternativa indicada es una propuesta y no proviene del curso.

Fuente: Respiratorio, prueba 5 (captura), P1

8. ¿Qué tratamiento antibiótico le parece más adecuado para un paciente cursando una neumonía grave, que requiere ventilación mecánica y uso de drogas vasoactivas?

a. Ceftriaxona sola
b. Ceftriaxona + penicilina
c. Clindamicina + penicilina
d. Ceftriaxona + levofloxacino
e. Cefotaximo + metronidazol

Respuesta propuesta: d. Ceftriaxona + levofloxacino

La prueba de origen no traía la respuesta ni la explicación; la alternativa indicada es una propuesta y no proviene del curso.

Fuente: Respiratorio, prueba 5 (captura), P11

9. Un paciente de 66 años, diagnosticado de EPOC leve, consulta por fiebre, asociada a tos con expectoración. Al examen se ve en buenas condiciones, algo decaído, con saturación arterial de 94% (su saturación basal es de 95%). Se auscultan sibilancias escasas bilaterales, espiración prolongada y algunos crépitos en la mitad superior del campo pulmonar izquierdo. Se solicita una radiografía de tórax, que demuestra una imagen de condensación en parte del lóbulo superior izquierdo. El tratamiento más adecuado para este paciente es:

a. Amoxicilina
b. Amoxicilina más ácido clavulánico
c. Clindamicina
d. Ceftriaxona
e. Ceftriaxona más levofloxacino

Respuesta propuesta: b. Amoxicilina más ácido clavulánico

La prueba de origen no traía la respuesta ni la explicación; la alternativa indicada es una propuesta y no proviene del curso.

Fuente: Respiratorio, prueba 6 (captura), P2

10. Un paciente presenta un cuadro de mialgias y fiebre alta, asociada a tos seca. Al tercer día evoluciona con dificultad respiratoria, con pequeños esfuerzos. Al examen físico está taquipneico, satura 91% y se auscultan crepitaciones pulmonares bilaterales, por lo que se solicita una radiografía de tórax, que muestra un patrón intersticial bilateral. Se solicita panel viral, que resulta positivo para virus influenza A. La conducta más adecuada es:

a. Enviar a domicilio con tratamiento sintomático
b. Enviar a domicilio con amoxicilina oral
c. Enviar a domicilio con levofloxacino oral
d. Hospitalizar, iniciar oxígeno y oseltamivir
e. Hospitalizar, iniciar oxígeno y ceftriaxona

Respuesta propuesta: d. Hospitalizar, iniciar oxígeno y oseltamivir

La prueba de origen no traía la respuesta ni la explicación; la alternativa indicada es una propuesta y no proviene del curso.

Fuente: Respiratorio, prueba 6 (captura), P7

11. Un paciente con un accidente vascular reciente presenta un cuadro de fiebre y tos con expectoración purulenta, de 2 días de evolución, que ha ido empeorando. Al examen físico está muy decaído, taquipneico, satura 91% a FIO2 ambiental y se auscultan crépitos pulmonares en la base derecha. Se solicita una radiografía de tórax que demuestra una zona de relleno alveolar en el lóbulo inferior derecho. El tratamiento más adecuado es:

a. Amoxicilina oral
b. Metronidazol endovenoso
c. Ceftriaxona endovenosa
d. Azitromicina oral
e. Ceftriaxona + clindamicina endovenosa

Respuesta propuesta: e. Ceftriaxona + clindamicina endovenosa

La prueba de origen no traía la respuesta ni la explicación; la alternativa indicada es una propuesta y no proviene del curso.

Fuente: Respiratorio, prueba 6 (captura), P13

12. La conducta más adecuada ante un paciente de 30 años, diagnosticado de neumonía adquirida en la comunidad, que no responde al tratamiento con amoxicilina oral, luego de 72 horas, persistiendo febril, decaído y con dolor con tope inspiratorio, es:

a. Mantener el tratamiento con amoxicilina y reevaluar en 24 horas
b. Iniciar tratamiento con amoxicilina + ácido clavulánico
c. Hospitalizar y solicitar radiografía de tórax
d. Solicitar cultivo de expectoración con antibiograma
e. Iniciar tratamiento con moxifloxacino oral

Respuesta propuesta: c. Hospitalizar y solicitar radiografía de tórax

La prueba de origen no traía la respuesta ni la explicación; la alternativa indicada es una propuesta y no proviene del curso.

Fuente: Respiratorio, prueba 6 (captura), P15

Tuberculosis (7)

13. Un paciente de 68 años, es diagnosticado de tuberculosis pulmonar, mediante baciloscopías de expectoración, por lo que inicia tratamiento con 4 fármacos (rifampicina, isoniazida, pirazinamida y

etambutol). Acude a control, un mes después, una baciloscopía de control, que resulta positiva. La conducta más adecuada es:

a. Mantener las indicaciones y controlar ambulatoriamente
b. Solicitar PPD y radiografía de tórax
c. Solicitar PCR para Mycobacterium tuberculosis
d. Suspender la pirazinamida y el etambutol
e. Derivar para tratamiento secundario, con 5 fármacos

Respuesta propuesta: a. Mantener las indicaciones y controlar ambulatoriamente

La prueba de origen no traía la respuesta ni la explicación; la alternativa indicada es una propuesta y no proviene del curso.

Fuente: Respiratorio, prueba 1 (captura), P1

14. Un paciente es diagnosticado de tuberculosis pulmonar, por lo que inicia terapia asociada, con 4 fármacos por 2 meses y luego con 2 fármacos por 4 meses más. Las baciloscopías de control resultaron todas negativas, por lo que es dado de alta. Sin embargo, acude a control 3 meses después por recurrencia de los síntomas respiratorios, con tos y expectoración mucopurulenta. La conducta más adecuada es:

a. Reiniciar el tratamiento antituberculoso
b. Solicitar PPD y radiografía de tórax
c. Solicitar radiografía de tórax y baciloscopías de expectoración
d. Iniciar antibióticos por vía endovenosa
e. Solicitar fibrobroncoscopía

Respuesta correcta: c. Solicitar radiografía de tórax y baciloscopías de expectoración

Explicación: Tiene una sospecha de recaída: recurrencia de los síntomas, luego de haber terminado exitosamente el tratamiento, lo que se confirma mediante baciloscopías. Si están positivas, se diagnostica la recaída tuberculosa y se debe volver a tratar con esquema primario, además de buscar la fuente de contagio, entre sus contactos. Si estuvieran negativas, se debe pedir un TAC de tórax, para descartar bronquiectasias, ya que la TBC puede secuelarse con bronquiectasias, las que, a su vez, pueden tener la misma clínica.

Fuente: Respiratorio, prueba 2 (captura), P7

15. Un paciente de 45 años es diagnosticado de TBC pulmonar bacilífera. Recibe 1 mes de tratamiento con rifampicina, isoniazida, pirazinamida y etambutol. Se controla con una baciloscopía, la que resulta positiva. La conducta más adecuada es:

a. Solicitar PPD y radiografía de tórax
b. Solicitar PPD
c. Mantener el tratamiento con los 4 fármacos y controlar en un mes con nueva baciloscopía
d. Derivar para inicio de tratamiento en esquema secundario
e. Solicitar TAC de tórax, de cortes finos

Respuesta propuesta: c. Mantener el tratamiento con los 4 fármacos y controlar en un mes con nueva baciloscopía

La prueba de origen no traía la respuesta ni la explicación; la alternativa indicada es una propuesta y no proviene del curso.

Fuente: Respiratorio, prueba 3 (captura), P6

16. Un paciente de 50 años, en situación de calle, presenta un cuadro clínico compatible con una tuberculosis pulmonar, por lo que se solicitan baciloscopías de expectoración, que resultan positivas. Se inicia tratamiento antituberculoso, el que recibe por un mes (rifampicina, isoniazida, pirazinamida y etambutol), sin embargo no acude a los controles posteriores y no termina su tratamiento. Usted lo recibe 4 meses después, con síntomas respiratorios, por lo que solicita nuevas baciloscopías, que resultan positivas. La conducta más adecuada es:

a. Retomar el tratamiento donde lo dejó
b. Diagnosticar fracaso a tratamiento e iniciar tratamiento secundario
c. Iniciar tratamiento con 2 fármacos: isoniazida y rifampicina
d. Solicitar PPD y decidir conducta según resultado
e. Reiniciar el tratamiento, desde el comienzo

Respuesta propuesta: e. Reiniciar el tratamiento, desde el comienzo

La prueba de origen no traía la respuesta ni la explicación; la alternativa indicada es una propuesta y no proviene del curso.

Fuente: Respiratorio, prueba 4 (captura), P4

17. Una paciente es diagnosticada de tuberculosis bacilífera, por lo que inicia tratamiento antituberculoso, con 4 drogas por 2 meses y luego con 2 drogas por 4 meses más. Las baciloscopías negativizaron al segundo mes de tratamiento y presentó mejora sintomática. Acude 4 meses después de haber terminado el tratamiento, con tos y expectoración, por lo que se solicita una nueva baciloscopía, que resulta positiva. El diagnóstico es:

a. Fracaso
b. Abandono
c. Recaída
d. Infección por Nocardia sp.
e. Infección por Mycobacterium avium

Respuesta propuesta: c. Recaída

La prueba de origen no traía la respuesta ni la explicación; la alternativa indicada es una propuesta y no proviene del curso.

Fuente: Respiratorio, prueba 5 (captura), P13

18. Un paciente de 68 años, indigente, en situación de calle, es diagnosticado de tuberculosis. Inicia tratamiento con 4 fármacos, por 2 meses y luego con dos fármacos. Sin embargo, solo alcanza a recibir un mes de tratamiento, cuando lo abandona. Usted lo recibe dos años después, sin síntomas. Se solicitan baciloscopías, que resultan negativas. La conducta más adecuada es:

a. Observar evolución
b. Retomar el tratamiento, donde lo dejó
c. Solicitar PCR para Mycobacterium tuberculosis
d. Reiniciar el tratamiento desde el principio, con 4 fármacos
e. Derivar para tratamiento secundario, con 5 fármacos

Respuesta propuesta: a. Observar evolución

La prueba de origen no traía la respuesta ni la explicación; la alternativa indicada es una propuesta y no proviene del curso.

Fuente: Respiratorio, prueba 6 (captura), P1

19. Un paciente de 67 años en tratamiento antituberculoso, secundaria a una tuberculosis pulmonar bacilífera, presenta las siguientes baciloscopías mensuales: Mes 1 (+), Mes 2 (-), Mes 3 (-), Mes 4 (+), Mes 5 (+). Actualmente recibe rifampicina e isoniazida dos veces a la semana. La conducta más adecuada es:

a. Mantener el tratamiento y controlar con nueva baciloscopía en un mes
b. Retomar el tratamiento con rifampicina, isoniazida, pirazinamida y etambutol
c. Solicitar radiografía de tórax y PPD
d. Diagnosticar una recaída y estudiar a los contactos del paciente
e. Solicitar cultivo de Koch con antibiograma y derivar a tratamiento secundario

Respuesta propuesta: e. Solicitar cultivo de Koch con antibiograma y derivar a tratamiento secundario

La prueba de origen no traía la respuesta ni la explicación; la alternativa indicada es una propuesta y no proviene del curso.

Fuente: Respiratorio, prueba 6 (captura), P14

Asma (12)

20. Un niño de 10 años presenta tos frecuente, al realizar ejercicio y también en la noche. En el último tiempo ha presentado además disnea, asociada a sibilancias, en particular en la noche. Hoy consulta en el servicio de urgencia, por dificultad respiratoria, tos intensa y disnea de reposo. Al examen físico está taquipneico, con frecuencia respiratoria de 40x', tose con frecuencia y se auscultan sibilancias espiratorias e inspiratorias en ambos pulmones, con prolongación de la espiración. Satura 90% a FIO2 ambiental. La conducta más adecuada es:

a. Administrar salbutamol en puff y enviar a domicilio
b. Administrar oxígeno para saturar más de 93%, realizar nebulizaciones con salbutamol e iniciar tratamiento antibiótico
c. Administrar oxígeno al 24%, nebulizar con salbutamol, administrar corticoides e iniciar antibióticos endovenosos
d. Iniciar oxígeno para saturar más de 93%, nebulizar con salbutamol, administrar corticoides y solicitar una radiografía de tórax
e. Realizar test de metacolina

Respuesta propuesta: d. Iniciar oxígeno para saturar más de 93%, nebulizar con salbutamol, administrar corticoides y solicitar una radiografía de tórax

La prueba de origen no traía la respuesta ni la explicación; la alternativa indicada es una propuesta y no proviene del curso.

Fuente: Respiratorio, prueba 1 (captura), P4

21. Un paciente asmático, consulta por disnea. Al examen físico se aprecia de buen aspecto, orientado, con FR: 23x', FC: 80x', PA: 120/80 mmHg, sin uso de musculatura accesoria ni cianosis. Se auscultan sibilancias espiratorias, sin otras alteraciones. Se solicitan gases arteriales, resultando PaO2: 40 mmHg, PaCO2: 47 mmHg, HCO3: 24 mEq/l, pH: 7,4. El diagnóstico más probable es:

a. Crisis asmática grave con insuficiencia respiratoria global
b. Crisis asmática grave con insuficiencia respiratoria parcial
c. Crisis asmática moderada con insuficiencia respiratoria e hipoventilación
d. Crisis asmática leve con hipoventilación
e. Crisis asmática leve con toma de gases venosos

Respuesta propuesta: e. Crisis asmática leve con toma de gases venosos

La prueba de origen no traía la respuesta ni la explicación; la alternativa indicada es una propuesta y no proviene del curso.

Fuente: Respiratorio, prueba 1 (captura), P17

22. Un paciente asmático, en tratamiento con salbutamol SOS y fluticasona 2 puff c/12 horas, consulta por disnea y tos, que aparecen en especial en la noche. Al examen físico presenta FC: 80x', PA: 120/80 mmHg, FR: 15x', SatO2: 98% a FIO2 ambiental, se auscultan algunas sibilancias espiratorias bilaterales. La conducta más adecuada es:

a. Reemplazar la fluticasona por mometasona
b. Agregar prednisona oral al tratamiento
c. Agregar ipatropio SOS al tratamiento
d. Indicar salbutamol c/4 horas, en lugar de indicarlo SOS
e. Agregar salmeterol c/12 horas al tratamiento

Respuesta propuesta: e. Agregar salmeterol c/12 horas al tratamiento

La prueba de origen no traía la respuesta ni la explicación; la alternativa indicada es una propuesta y no proviene del curso.

Fuente: Respiratorio, prueba 1 (captura), P18

23. Un paciente de 30 años presenta tos frecuente y en ocasiones, disnea en relación al ejercicio y cuando se resfría. Refiere que tose mucho en la noche y que "le silba el pecho". Al examen físico está en buenas condiciones, pero se aprecia espiración prolongada. Su radiografía de tórax muestra aplanamiento del diafragma y su espirometría muestra un patrón obstructivo, que mejora con salbutamol. La conducta más adecuada es:

a. Iniciar corticoides inhalados SOS y salmeterol según horario
b. Iniciar salbutamol inhalado SOS y salmeterol según horario
c. Iniciar salbutamol inhalado SOS y corticoides según horario
d. Iniciar salbutamol inhalado SOS, corticoides orales y una asociación de corticoides y salmeterol inhalados según horario
e. Solicitar test de provocación con metacolina

Respuesta correcta: c. Iniciar salbutamol inhalado SOS y corticoides según horario

Explicación: Es un asma clínico, confirmado ya con la espirometría. Se debe tratar con corticoides por horario más salbutamol SOS. La opción D (salbutamol, más corticoides, más salmeterol) sería correcta como tratamiento de segunda línea. La opción A (salbutamol más salmeterol), sería correcto como tratamiento sintomático del EPOC. No es necesario pedir el test de metacolina, ya que el diagnóstico fue confirmado con la espirometría (el test de metacolina se pide como apoyo diagnóstico en paciente con sospecha de asma con síntomas intermitentes, ya que en ellos la espirometría resulta normal).

Fuente: Respiratorio, prueba 2 (captura), P10

24. Un paciente asmático consulta por disnea de reposo, que no ha cedido a pesar del uso frecuente de salbutamol. Al examen físico está taquipneico a 28 rpm, con aumento del diámetro anteroposterior. Presenta sibilancias espiratorias intensas, bilaterales y uso de musculatura accesoria. Su saturación arterial es de 88% a FIO2 ambiental. La conducta más adecuada es:

a. Administrar oxígeno al 24%, nebulizar con salbutamol y administrar corticoides y antibióticos por vía endovenosa
b. Administrar oxígeno hasta normalizar la saturación arterial, nebulizar con salbutamol y administrar corticoides por vía endovenosa
c. Administrar oxígeno al 100% y conectar a ventilación mecánica no invasiva
d. Administrar oxígeno a 2 L/min, administrar adrenalina racémica y corticoides en nebulización

e. Administrar oxígeno hasta normalizar la saturación arterial, nebulizar con salbutamol, administrar corticoides orales e iniciar ceftriaxona endovenosa

Respuesta propuesta: b. Administrar oxígeno hasta normalizar la saturación arterial, nebulizar con salbutamol y administrar corticoides por vía endovenosa

La prueba de origen no traía la respuesta ni la explicación; la alternativa indicada es una propuesta y no proviene del curso.

Fuente: Respiratorio, prueba 3 (captura), P8

25. Un paciente asmático está en tratamiento con fluticasona inhalada, dos veces al día, la que usa con una aerocámara. Además usa salbutamol cuando está con síntomas. Presenta síntomas nocturnos cerca de 2 veces a la semana y tose con frecuencia, en especial después de realizar esfuerzos. La conducta más adecuada es:

a. Reemplazar la fluticasona por mometasona inhalada
b. Reemplazar la fluticasona por prednisona oral
c. Reemplazar el salbutamol por ipatropio
d. Reemplazar el salbutamol por formoterol SOS
e. Agregar salmeterol inhalado cada 12 horas al tratamiento

Respuesta propuesta: e. Agregar salmeterol inhalado cada 12 horas al tratamiento

La prueba de origen no traía la respuesta ni la explicación; la alternativa indicada es una propuesta y no proviene del curso.

Fuente: Respiratorio, prueba 3 (captura), P20

26. Un niño de 10 años, asmático, en tratamiento con fluticasona y salbutamol, consulta por un cuadro de disnea, que no ha cedido a pesar del uso frecuente de salbutamol. Al examen se auscultan sibilancias bilaterales, inspiratorias y espiratorias y se observa uso de musculatura accesoria y taquipnea. ¿Qué examen es más adecuado para determinar la gravedad de este paciente?

a. PEF (flujo espiratorio máximo)
b. Gases en sangre arterial
c. Test de metacolina
d. Espirometría
e. Radiografía de tórax

Respuesta propuesta: a. PEF (flujo espiratorio máximo)

La prueba de origen no traía la respuesta ni la explicación; la alternativa indicada es una propuesta y no proviene del curso.

Fuente: Respiratorio, prueba 4 (captura), P8

27. Un niño de 12 meses ha presentado 3 episodios de obstrucción bronquial, los que respondieron bien después del manejo en urgencia durante dos horas con salbutamol inhalado y oxígeno. Usted lo recibe al día siguiente del tercer episodio, derivado por el médico de urgencias. No presenta otros síntomas, está en buenas condiciones, manteniendo algo de tos y su examen físico es normal. La indicación más adecuada es:

a. Indicar uso de salbutamol SOS
b. Iniciar corticoides inhalados cada 12 horas y salbutamol SOS
c. Iniciar salmeterol inhalado cada 12 horas y salbutamol SOS
d. Solicitar espirometría
e. Indicar salbutamol cada 6 horas por 3 meses

Respuesta propuesta: b. Iniciar corticoides inhalados cada 12 horas y salbutamol SOS

La prueba de origen no traía la respuesta ni la explicación; la alternativa indicada es una propuesta y no proviene del curso.

Fuente: Respiratorio, prueba 4 (captura), P16

28. ¿Qué medicamento es más importante para prevenir la aparición de crisis asmáticas en un paciente asmático?

a. Betaagonistas de larga acción inhalados
b. Corticoides inhalados
c. Betaagonistas de corta acción inhalados
d. Antihistamínicos orales
e. Inhibidores del receptor de leucotrienos orales

Respuesta propuesta: b. Corticoides inhalados

La prueba de origen no traía la respuesta ni la explicación; la alternativa indicada es una propuesta y no proviene del curso.

Fuente: Respiratorio, prueba 4 (captura), P17

29. Un paciente de 10 años presenta tos nocturna y sibilancias luego de realizar deporte o durante las infecciones respiratorias virales. Al examen físico sólo presenta alargamiento de la espiración. ¿Qué examen es más adecuado para confirmar la sospecha diagnóstica?

a. Test de difusión de CO
b. Espirometría
c. Prick test
d. Radiografía de tórax
e. TAC de tórax de cortes finos

Respuesta propuesta: b. Espirometría

La prueba de origen no traía la respuesta ni la explicación; la alternativa indicada es una propuesta y no proviene del curso.

Fuente: Respiratorio, prueba 5 (captura), P14

30. ¿Cuál de los siguientes tratamientos le parece más adecuado para un paciente asmático, que presenta síntomas 1 a 2 veces por semana, los que controla con salbutamol?

a. Mantener el salbutamol SOS
b. Agregar salmeterol inhalado cada 12 horas
c. Agregar fluticasona inhalada cada 12 horas
d. Agregar aspirina oral cada 12 horas
e. Agregar ipatropio SOS, asociado con el salbutamol

Respuesta propuesta: a. Mantener el salbutamol SOS

La prueba de origen no traía la respuesta ni la explicación; la alternativa indicada es una propuesta y no proviene del curso.

Fuente: Respiratorio, prueba 5 (captura), P18

31. Un niño de 10 años presenta tos frecuente, al realizar ejercicio y también en la noche. Al examen físico se auscultan algunas sibilancias espiratorias en ambos pulmones. Se solicita una espirometría, que demuestra un patrón obstructivo moderado, que mejora con salbutamol. La conducta más adecuada es:

a. Indicar salbutamol inhalado cada 6 horas
b. Indicar corticoides inhalados cada 12 horas, más salbutamol en caso de síntomas
c. Indicar salmeterol inhalado cada 12 horas, más salbutamol en caso de síntomas
d. Indicar salmeterol inhalado en caso de síntomas y corticoides orales

e. Iniciar corticoides inhalados cada 12 horas, más salmeterol en caso de síntomas

Respuesta propuesta: b. Indicar corticoides inhalados cada 12 horas, más salbutamol en caso de síntomas

La prueba de origen no traía la respuesta ni la explicación; la alternativa indicada es una propuesta y no proviene del curso.

Fuente: Respiratorio, prueba 6 (captura), P4

Enfermedad pulmonar obstructiva crónica (14)

32. Un paciente de 71 años, fumador de 1 cajetilla al día, presenta disnea de esfuerzos, que aparece al caminar una cuadra. Al examen físico presenta aumento del diámetro anteroposterior y escasas sibilancias espiratorias. El diagnóstico más probable es:

a. Asma
b. EPOC
c. Fibrosis pulmonar
d. Cáncer pulmonar
e. Bronquiectasias

Respuesta propuesta: b. EPOC

La prueba de origen no traía la respuesta ni la explicación; la alternativa indicada es una propuesta y no proviene del curso.

Fuente: Respiratorio, prueba 1 (captura), P5

33. El EPOC se diagnostica mediante:

a. La clínica sola
b. La radiografía de tórax
c. La tomografía axial computada de tórax
d. La broncoscopía
e. La clínica más la espirometría

Respuesta propuesta: e. La clínica más la espirometría

La prueba de origen no traía la respuesta ni la explicación; la alternativa indicada es una propuesta y no proviene del curso.

Fuente: Respiratorio, prueba 1 (captura), P10

34. Un paciente con antecedente de EPOC tabáquico, severo, de 10 años de evolución, consulta por cuadro de astenia y mayor disnea de la habitual, asociada a edema de extremidades inferiores y hepatomegalia. Actualmente no fuma y sigue tratamiento con broncodilatadores y corticoides inhalados. El examen físico no aporta mayor información. El diagnóstico más probable es:

a. Cardiopatía coronaria
b. Fibrosis pulmonar
c. Cáncer
d. Cor pulmonar
e. Hipertensión pulmonar

Respuesta propuesta: d. Cor pulmonar

La prueba de origen no traía la respuesta ni la explicación; la alternativa indicada es una propuesta y no proviene del curso.

Fuente: Respiratorio, prueba 1 (captura), P13

35. En un paciente con EPOC estable, ¿qué criterio es el más adecuado para determinar la severidad?

a. Respuesta a corticoides inhalados
b. Respuesta a broncodilatadores
c. Relación VEF1/CVF
d. VEF1
e. Gases en sangre arterial

Respuesta propuesta: d. VEF1

La prueba de origen no traía la respuesta ni la explicación; la alternativa indicada es una propuesta y no proviene del curso.

Fuente: Respiratorio, prueba 1 (captura), P15

36. Un paciente de 60 años, fumador, consulta por disnea que aparece al caminar una cuadra. Al examen físico presenta espiración prolongada y aumento del diámetro torácico. Se solicita una radiografía de tórax que muestra aplanamiento del diafragma, gases arteriales que son normales y una espirometría que muestra VEF1: 75% del teórico, CVF: 105% del teórico, VEF1/CVF: 60%. La conducta más adecuada es:

a. Iniciar corticoides orales y suspender el cigarrillo
b. Iniciar oxígeno domiciliario y suspender el cigarrillo
c. Iniciar corticoides inhalados y suspender el cigarrillo
d. Iniciar broncodilatadores inhalados y suspender el cigarrillo
e. Iniciar antibióticos orales y suspender el cigarrillo

Respuesta propuesta: d. Iniciar broncodilatadores inhalados y suspender el cigarrillo

La prueba de origen no traía la respuesta ni la explicación; la alternativa indicada es una propuesta y no proviene del curso.

Fuente: Respiratorio, prueba 3 (captura), P2

37. ¿Cuál de las siguientes conductas es MENOS indicada en un paciente EPOC cursando una neumonía y que satura 80% a FIO2 ambiental?

a. Iniciar oxígeno al 50%
b. Administrar corticoides sistémicos
c. Realizar nebulización con broncodilatadores de corta acción por vía inhalatoria
d. Solicitar gases de sangre arterial
e. Administrar antibióticos endovenosos

Respuesta propuesta: a. Iniciar oxígeno al 50%

La prueba de origen no traía la respuesta ni la explicación; la alternativa indicada es una propuesta y no proviene del curso.

Fuente: Respiratorio, prueba 3 (captura), P11

38. Un paciente de 65 años, fumador de una cajetilla al día, consulta por disnea de esfuerzos de un mes de evolución. Al examen físico se constata aumento del diámetro anteroposterior del tórax, asociado a espiración prolongada y algunas sibilancias espiratorias. El diagnóstico más probable es:

a. Bronquiectasias
b. Cáncer bronquial
c. Bronquitis crónica
d. Enfermedad pulmonar obstructiva crónica
e. Fibrosis pulmonar

Respuesta propuesta: d. Enfermedad pulmonar obstructiva crónica

La prueba de origen no traía la respuesta ni la explicación; la alternativa indicada es una propuesta y no proviene del curso.

Fuente: Respiratorio, prueba 4 (captura), P1

39. Un paciente de 67 años, diagnosticado de EPOC tabáquico, en tratamiento con broncodilatadores de larga acción, consulta por disnea mayor a la habitual, asociada a cianosis y tos con expectoración. Se inicia oxígeno al 35%, evolucionando con compromiso de conciencia. Se solicitan gases arteriales, que son compatibles con una insuficiencia respiratoria aguda, de tipo global. La conducta más adecuada es:

a. Realizar nebulizaciones con corticoides
b. Suspender el oxígeno
c. Aumentar el oxígeno a 100%
d. Realizar nebulizaciones con ipatropio y salbutamol
e. Conectar a ventilación mecánica

Respuesta propuesta: e. Conectar a ventilación mecánica

La prueba de origen no traía la respuesta ni la explicación; la alternativa indicada es una propuesta y no proviene del curso.

Fuente: Respiratorio, prueba 4 (captura), P10

40. ¿Cuál de las siguientes medidas incide más en el pronóstico de un paciente diagnosticado de EPOC?

a. Realizar actividad física
b. Abandonar el hábito tabáquico
c. Usar corticoides inhalados
d. Usar broncodilatadores de corta acción
e. Usar broncodilatadores de larga acción

Respuesta propuesta: b. Abandonar el hábito tabáquico

La prueba de origen no traía la respuesta ni la explicación; la alternativa indicada es una propuesta y no proviene del curso.

Fuente: Respiratorio, prueba 4 (captura), P12

41. Un paciente EPOC crónico, en tratamiento con broncodilatadores, consulta por la opción de uso de oxígeno domiciliario. Lo más correcto es indicarle que:

a. Está indicado en todos los pacientes con EPOC
b. Está indicado solo en aquellos pacientes que continúan fumando
c. Está indicado solo en pacientes con insuficiencia respiratoria crónica grave, o con comorbilidades específicas
d. Está indicado solo en pacientes con síntomas a pesar del uso de corticoides y broncodilatadores
e. Está indicado solo en pacientes con disnea de reposo

Respuesta propuesta: c. Está indicado solo en pacientes con insuficiencia respiratoria crónica grave, o con comorbilidades específicas

La prueba de origen no traía la respuesta ni la explicación; la alternativa indicada es una propuesta y no proviene del curso.

Fuente: Respiratorio, prueba 5 (captura), P9

42. Un paciente EPOC, presenta marcado aumento de la disnea de 24 horas de evolución, que en las últimas horas se volvió intensa incluso en el reposo. Al examen físico presenta cianosis y taquipnea importante. Se solicitan gases arteriales que muestran PaO2: 45 mmHg, PaCO2: 65 mmHg y pH: 7,26. La conducta más adecuada es:

a. Iniciar oxígeno al 100% y nebulizarlo con salbutamol de inmediato

b. Administrar corticoides endovenosos y realizar nebulizaciones con salbutamol

c. Conectar a ventilación mecánica no invasiva

d. Realizar nebulizaciones con corticoides y broncodilatadores de larga acción

e. Administrar aminofilina endovenosa, albutamol inhalado y oxígeno por mascarilla de recirculación

Respuesta propuesta: c. Conectar a ventilación mecánica no invasiva

La prueba de origen no traía la respuesta ni la explicación; la alternativa indicada es una propuesta y no proviene del curso.

Fuente: Respiratorio, prueba 5 (captura), P17

43. Un paciente de 70 años, diagnosticado de EPOC severo, en tratamiento con broncodilatadores de larga y corta acción, acude al servicio de urgencia, por gran deterioro de la función respiratoria. Al examen está muy taquipneico, con cianosis y sibilancias que se escuchan, sin necesidad del fonendoscopio. Se solicitan gases arteriales, que muestran una PaO2 de 45, PCO2 de 66 y pH de 7,28. La conducta más adecuada es:

a. Administrar corticoides y antibióticos, iniciar oxígeno por naricera a 2 litros/min y nebulizar con salbutamol

b. Administrar corticoides y antibióticos, iniciar oxígeno por mascarilla al 50% y realizar nebulizaciones con salbutamol

c. Administrar corticoides y antibióticos, iniciar oxígeno al 100% y realizar nebulizaciones con salbutamol e ipatropio

d. Administrar corticoides y antibióticos y conectar a ventilación asistida (con BiPAP)

e. Administrar corticoides y antibióticos y nebulizar con salbutamol e ipatropio

Respuesta propuesta: d. Administrar corticoides y antibióticos y conectar a ventilación asistida (con BiPAP)

La prueba de origen no traía la respuesta ni la explicación; la alternativa indicada es una propuesta y no proviene del curso.

Fuente: Respiratorio, prueba 6 (captura), P5

44. Un paciente de 61 años, con antecedente de EPOC, en tratamiento con corticoides y broncodilatadores inhalados presenta aumento de su disnea basal, asociado a fiebre y expectoración abundante. Al examen se aprecia orientado, taquipneico, con FR: 27x', FC: 91x', PA: 140/100 mmHg, SatO2: 80% a FIO2 ambiental. Se ausculta disminución del murmullo pulmonar, sibilancias intensas y estertores bilaterales. La conducta más adecuada es:

a. Administrar salbutamol y corticoides inhalados, oxígeno a bajas dosis e iniciar antibióticos de amplio espectro

b. Realizar nebulización con salbutamol, administrando oxígeno a bajas dosis, sin necesidad de corticoides ni de antibióticos

c. Administrar oxígeno en alta concentración, realizar nebulización con corticoides e iniciar antibióticos orales

d. Administrar oxígeno al 24%, realizar nebulización con salbutamol, administrar corticoides sistémicos e iniciar antibióticos de amplio espectro endovenosos

e. Administrar oxígeno a 2 litros por minuto, realizar nebulización con corticoides y broncodilatadores de corta acción e iniciar antibióticos endovenosos

Respuesta propuesta: d. Administrar oxígeno al 24%, realizar nebulización con salbutamol, administrar corticoides sistémicos e iniciar antibióticos de amplio espectro endovenosos

La prueba de origen no traía la respuesta ni la explicación; la alternativa indicada es una propuesta y no proviene del curso.

Fuente: Respiratorio, prueba 6 (captura), P11

45. ¿Cuál de los siguientes pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica tiene indicación de oxígeno domiciliario a permanencia, para aumentar la sobrevida?

a. Paciente de 67 años, con síntomas muy marcados y VEF 1 del 30% del teórico
b. Paciente con EPOC estable que presenta gases arteriales con PaO2: 56 mmHg y PaCO2: 40 mmHg
c. Paciente con EPOC estable, con PaO2: 58 mmHg y PaCO2: 38 mmHg y diagnóstico de hipertensión pulmonar
d. Paciente con EPOC estable que presenta hematocrito: 50%, PaO2: 68 mmHg y PaCO2: 38 mmHg
e. Paciente con EPOC estable, con VEF1/CVF correspondiente al 43%

Respuesta propuesta: c. Paciente con EPOC estable, con PaO2: 58 mmHg y PaCO2: 38 mmHg y diagnóstico de hipertensión pulmonar

La prueba de origen no traía la respuesta ni la explicación; la alternativa indicada es una propuesta y no proviene del curso.

Fuente: Respiratorio, prueba 6 (captura), P17

Derrame pleural y empiema (12)

46. Un paciente de 69 años, presenta un cuadro de tos con expectoración, asociada a fiebre y dolor tipo puntada de costado. Al examen físico se ausculta importante disminución del murmullo pulmonar derecho, por lo que se solicita una radiografía de tórax, que muestra un derrame pleural, que ocupa la mitad del campo pulmonar derecho. Se realiza una punción pleural, que da salida a un líquido amarillo turbio, con LDH de 310 (LDH plasmática 220), 3.500 células por mm3, con un 90% de polimorfonucleares, pH de 7,0 y ADA de 113 UI/L. El diagnóstico más probable es:

a. Tuberculosis pleural
b. Empiema
c. Derrame maligno (secundario a cáncer)
d. Derrame paraneumónico simple
e. Transudado pleural

Respuesta propuesta: b. Empiema

La prueba de origen no traía la respuesta ni la explicación; la alternativa indicada es una propuesta y no proviene del curso.

Fuente: Respiratorio, prueba 1 (captura), P3

47. Un paciente consulta por un cuadro de dolor torácico, tipo puntada, con tope inspiratorio, de una semana de evolución, que se ha intensificado en el último tiempo. El examen físico es compatible con un derrame pleural derecho, que se confirma con una radiografía de tórax. Se realiza toracentesis que da salida a líquido amarillo transparente, con proteínas: 6,1 g/dl, LDH: 180 UI/l, 650 células por mm3, con 86% de mononucleares y ADA: 77 UI/l. La tinción de Gram no visualiza bacterias. El análisis sanguíneo muestra proteínas plasmáticas: 7,5 g/dl y LDH plasmática: 210 UI/l. El diagnóstico más probable es:

a. Empiema
b. Derrame paraneumónico simple
c. Derrame pleural canceroso
d. Tuberculosis pleural
e. Insuficiencia cardíaca congestiva

Respuesta propuesta: d. Tuberculosis pleural

La prueba de origen no traía la respuesta ni la explicación; la alternativa indicada es una propuesta y no proviene del curso.

Fuente: Respiratorio, prueba 1 (captura), P11

48. Un paciente de 60 años presenta disnea y dolor torácico tipo puntada, razón por la cual se realiza una radiografía de tórax, que muestra un derrame pleural de tamaño moderado, el que se punciona, obteniéndose un líquido amarillo, citrino, con proteínas de 6,2 g/dl, LDH: 300 por mm3, células 150 por mm3, con 95% mononucleares. El diagnóstico más probable es:

a. Empiema
b. Derrame pleural tuberculoso
c. Insuficiencia cardíaca
d. Derrame paraneumónico simple
e. Síndrome nefrótico

Respuesta correcta: b. Derrame pleural tuberculoso

Explicación: Es un exudado (proteínas elevadas y LDH mayor a 180), de tipo mononuclear, por lo que es una TBC o un cáncer (no está en las opciones). El empiema y el derrame paraneumónico son exudados polimorfonucleares. La ICC y el síndrome nefrótico son transudados (LDH y proteínas bajas).

Fuente: Respiratorio, prueba 2 (captura), P1

49. Un paciente de 17 años, cursando una neumonía del lóbulo inferior izquierdo ATS1, en tratamiento con amoxicilina, consulta 72 horas después del inicio del tratamiento, por persistir con fiebre y compromiso del estado general. Se solicita una nueva radiografía que muestra un derrame pleural moderado. Se realiza punción, dando salida un exudado de predominio polimorfonuclear, con lactato de 10 mmol/L y pH: 7,15. La tinción de Gram no visualiza bacterias. La conducta más adecuada es:

a. Hospitalizar, remplazar la amoxicilina por ceftriaxona endovenosa e instalar un tubo pleural
b. Hospitalizar, remplazar la amoxicilina por ceftriaxona endovenosa y drenar el derrame, mediante toracocentesis
c. Agregar ácido clavulánico al tratamiento
d. Realizar biopsias pleurales
e. Administrar antibióticos y trombolíticos intrapleurales

Respuesta correcta: a. Hospitalizar, remplazar la amoxicilina por ceftriaxona endovenosa e instalar un tubo pleural

Explicación: Se trata de un derrame paraneumónico complicado (DPNC) o infectado (equivale al empiema, solo que el empiema es un diagnóstico clínico: pus en la pleura, mientras el que el DPNC es un diagnóstico de laboratorio). Se caracteriza por ser un exudado polimorfonuclear con pH menor a 7,2 y/o lactato mayor a 5 mmol/L. Si el cultivo o el Gram están positivos, también corresponde a un DPNC. Al igual que el empiema, se trata con drenaje, más instalación de un tubo pleural, más antibióticos. Solo si no drena, por estar loculado, se administran trombolíticos intrapleurales y si no responden, se procede a la decorticación quirúrgica, por videotoracoscopía. La B sería correcta en un derrame paraneumónico simple (DPNS). La C sería correcta si no hubiese habido derrame asociado y simplemente la neumonía no respondía a tratamiento y la radiografía descartaba complicaciones. La D habría sido correcta, si el derrame hubiese sido un exudado mononuclear (tanto TBC pleural, como el cáncer se diagnostican con biopsia).

Fuente: Respiratorio, prueba 2 (captura), P6

50. Un paciente presenta un cuadro de tos con expectoración y dolor tipo puntada de costado. Se solicita una radiografía que muestra una zona de relleno alveolar, asociada a un derrame pleural moderado. Se punciona el derrame, dando salida a un líquido pleural turbio, con 2.000 células por mm3, 96% polimorfonucleares, con pH: 7,0, lactato: 12 mmol/L, LDH: 230 UI/L, proteínas: 7 g/dl y ADA: 100 UI/L. La conducta más adecuada es:

a. Iniciar tratamiento antituberculoso
b. Solicitar biopsias pleurales
c. Iniciar tratamiento antibiótico endovenoso e instalar un tubo pleural con trampa de agua
d. Iniciar tratamiento antibiótico endovenoso y drenar el drenaje mediante la toracocentesis
e. Iniciar tratamiento antibiótico endovenoso, biasociado, con cobertura para anaerobios

Respuesta propuesta: c. Iniciar tratamiento antibiótico endovenoso e instalar un tubo pleural con trampa de agua

La prueba de origen no traía la respuesta ni la explicación; la alternativa indicada es una propuesta y no proviene del curso.

Fuente: Respiratorio, prueba 3 (captura), P7

51. Un paciente de 60 años, diagnosticado de derrame pleural, se realiza toracocentesis diagnóstica, obteniéndose un líquido amarillo, transparente, con proteínas de 2,1 g/dl, LDH: 90 UI/l, células: 60 x mm3, con 80% mononucleares, pH: 7,4 y lactato: 3 mmol/l. Las proteínas plasmáticas son 6,4 g/dl y la LDH plasmática es 190 UI/l. El diagnóstico más probable es:

a. Tuberculosis
b. Cáncer
c. Empiema
d. Derrame paraneumónico simple
e. Insuficiencia cardíaca

Respuesta propuesta: e. Insuficiencia cardíaca

La prueba de origen no traía la respuesta ni la explicación; la alternativa indicada es una propuesta y no proviene del curso.

Fuente: Respiratorio, prueba 3 (captura), P15

52. El derrame pleural canceroso se caracteriza por ser:

a. Un transudado pleural mononuclear
b. Un transudado pleural polimorfonuclear con pH normal
c. Un exudado pleural mononuclear
d. Un exudado pleural polimorfonuclear con pH normal
e. Un exudado pleural con ADA mayor a 50 UI/L

Respuesta propuesta: c. Un exudado pleural mononuclear

La prueba de origen no traía la respuesta ni la explicación; la alternativa indicada es una propuesta y no proviene del curso.

Fuente: Respiratorio, prueba 3 (captura), P18

53. Un paciente de 70 años consulta por malestar general, fiebre, tos con expectoración mucopurulenta y dolor tipo puntada de costado. Se solicita una radiografía de tórax, que muestra derrame pulmonar izquierdo de un 60% del hemitórax. Se realiza pleurocentesis, obteniéndose un líquido con 1.200 células por mm3, con un 95% de polimorfonucleares, LDH: 210 UI/L, ADA: 110 UI/L y pH: 7,0. El diagnóstico más probable es:

a. Cáncer

b. Derrame paraneumónico simple
c. Tuberculosis pulmonar
d. Transudado pleural
e. Empiema

Respuesta propuesta: e. Empiema

La prueba de origen no traía la respuesta ni la explicación; la alternativa indicada es una propuesta y no proviene del curso.

Fuente: Respiratorio, prueba 4 (captura), P5

54. Un paciente de 65 años consulta por disnea y dolor tipo puntada de costado, de una semana de evolución. Se solicita una radiografía de tórax, que muestra un derrame pleural derecho de tamaño moderado. Se realiza toracocentesis y estudio del líquido pleural obteniéndose un líquido de color amarillo, transparente, con proteínas de 5 g/dl y LDH: 200 UI/L. Presenta 110 células por mm3, con un 90% de mononucleares y ADA de 10 UI/L. La LDH plasmática es 300 mg/dl y las proteínas plasmáticas son 7,9 mg/dl. El diagnóstico más probable es:

a. Derrame tuberculoso
b. Derrame canceroso
c. Derrame plaraneumónico simple
d. Insuficiencia cardíaca
e. Quilotórax

Respuesta propuesta: b. Derrame canceroso

La prueba de origen no traía la respuesta ni la explicación; la alternativa indicada es una propuesta y no proviene del curso.

Fuente: Respiratorio, prueba 4 (captura), P7

55. Un paciente consulta por dolor torácico, tipo puntada de costado, por lo que se realiza una radiografía de tórax, que muestra un derrame pleural moderado. Se procede a la toracocentesis, obteniéndose un líquido pleural amarillo, transparente, con pH: 7,30, lactato: 2,5 mmol/L, LDH: 190 UI/L, proteínas: 4,0 g/L, células: 560 por mm3, con 90% de mononucleares. La LDH plasmática es 250 UI/L y las proteínas plasmáticas son 7,0 g/dL. El diagnóstico más probable es:

a. Empiema
b. Derrame paraneumónico simple
c. Tuberculosis pleural
d. Tromboembolismo pulmonar crónico
e. Insuficiencia cardíaca

Respuesta propuesta: c. Tuberculosis pleural

La prueba de origen no traía la respuesta ni la explicación; la alternativa indicada es una propuesta y no proviene del curso.

Fuente: Respiratorio, prueba 5 (captura), P3

56. Un paciente cursando un síndrome neumónico, se realiza una radiografía, que visualiza una zona de condensación en el lóbulo inferior izquierdo, asociado a un derrame pleural que abarca el 25% inferior del campo pulmonar izquierdo. La conducta más adecuada es:

a. Instalar un tubo pleural y administrar antibióticos por vía endovenosa e intrapleural
b. Iniciar antibióticos y realizar pleurocentesis, con análisis del líquido pleural y decidir conducta según hallazgos
c. Iniciar ceftriaxona, asociada a fármacos antituberculosos

d. Iniciar antibióticos y solicitar biopsias pleurales
e. Indicar ceftriaxona + clindamicina y controlar evolución

Respuesta propuesta: b. Iniciar antibióticos y realizar pleurocentesis, con análisis del líquido pleural y decidir conducta según hallazgos

La prueba de origen no traía la respuesta ni la explicación; la alternativa indicada es una propuesta y no proviene del curso.

Fuente: Respiratorio, prueba 5 (captura), P15

57. Un paciente de 69 años, consulta por disnea de esfuerzo de una semana de evolución. Al examen físico se ausculta importante disminución del murmullo pulmonar derecho, por lo que se solicita una radiografía de tórax, que muestra un derrame pleural, que ocupa más de la mitad del campo pulmonar derecho. Se realiza una punción pleural, que da salida a un líquido amarillo transparente, con LDH de 210 (LDH plasmática 220), 500 células por mm3, con un 90% de mononucleares, pH de 7,4 y ADA de 13 UI/L. El diagnóstico más probable es:

a. Tuberculosis pleural
b. Empiema
c. Derrame maligno (secundario a cáncer)
d. Derrame paraneumónico simple
e. Transudado pleural

Respuesta propuesta: c. Derrame maligno (secundario a cáncer)

La prueba de origen no traía la respuesta ni la explicación; la alternativa indicada es una propuesta y no proviene del curso.

Fuente: Respiratorio, prueba 6 (captura), P3

Enfermedad pulmonar difusa y fibrosis (6)

58. La fibrosis pulmonar idiopática se presenta espirométricamente como:

a. Un patrón obstructivo que mejora con broncodilatador
b. Un patrón obstructivo que no mejora con broncodilatador
c. Un patrón restrictivo que no mejora con broncodilatador
d. Un patrón mixto que mejora con broncodilatador
e. Una espirometría normal

Respuesta propuesta: c. Un patrón restrictivo que no mejora con broncodilatador

La prueba de origen no traía la respuesta ni la explicación; la alternativa indicada es una propuesta y no proviene del curso.

Fuente: Respiratorio, prueba 1 (captura), P14

59. La fibrosis pulmonar se caracteriza por todo lo siguiente, EXCEPTO:

a. Disminución de la capacidad vital forzada (CVF), respecto al valor teórico
b. Hipocratismo digital
c. Disminución de la relación VEF1/CVF
d. Disminución de la difusión de monóxido de carbono (CO)
e. Patrón en panal de abejas en la radiografía de tórax

Respuesta correcta: c. Disminución de la relación VEF1/CVF

Explicación: Preguntan la excepción (el Eunacom real no tiene este tipo de preguntas, pero sirven para repasar la materia). La fibrosis pulmonar tiene un patrón restrictivo en la espirometría (caída de la CVF y

del VEF1, pero con normalidad de la relación VEF1/CVF). Por tanto, no puede ser la C, ya que la disminución de la relación VEF1/CVF es de los cuadros obstructivos. Puede tener hipocratismo digital, además, es clásico el patrón "en panal de abejas" en la radiografía (a veces se describe como "en vidrio esmerilado"). Finalmente, es un trastorno de la difusión, por lo que altera la prueba de difusión de CO.

Fuente: Respiratorio, prueba 2 (captura), P3

60. ¿Cuál de los siguientes hallazgos es MENOS compatible con una fibrosis pulmonar?

a. Hipocratismo digital
b. Desaturación arterial con el ejercicio
c. Crepitaciones pulmonares intensas
d. Aumento de la capacidad vital forzada
e. Radiografía con patrón intersticial en panal de abeja

Respuesta propuesta: d. Aumento de la capacidad vital forzada

La prueba de origen no traía la respuesta ni la explicación; la alternativa indicada es una propuesta y no proviene del curso.

Fuente: Respiratorio, prueba 3 (captura), P4

61. Un paciente, diagnosticado de "disnea en estudio", se realiza una espirometría que demuestra VEF1: 56% del teórico, CVF: 60% del teórico, VEF1/CVF: 80%, que no mejora con broncodilatadores. El diagnóstico más probable, de entre los siguientes, es:

a. Asma
b. Fibrosis pulmonar
c. EPOC
d. Bronquiectasias
e. Hipertensión pulmonar primaria

Respuesta propuesta: b. Fibrosis pulmonar

La prueba de origen no traía la respuesta ni la explicación; la alternativa indicada es una propuesta y no proviene del curso.

Fuente: Respiratorio, prueba 4 (captura), P11

62. Un paciente de 60 años consulta por disnea de esfuerzos desde hace un mes, que aparecen al caminar una cuadra. Además, presenta tos, sin expectoración. Al examen físico presenta hipocratismo digital y crepitaciones pulmonares intensas, bilaterales, mayores en las bases pulmonares. El diagnóstico de sospecha es:

a. Neumonía atípica
b. Fibrosis pulmonar
c. EPOC
d. Asma
e. Cáncer pulmonar

Respuesta propuesta: b. Fibrosis pulmonar

La prueba de origen no traía la respuesta ni la explicación; la alternativa indicada es una propuesta y no proviene del curso.

Fuente: Respiratorio, prueba 5 (captura), P2

63. Una paciente de 52 años, fumador, presenta disnea de esfuerzos progresiva, de 6 meses de evolución. Al examen físico se auscultan crépitos bilaterales. La radiografía de tórax muestra un patrón en panal de abejas en ambas bases. El diagnóstico más importante es:

a. EPOC
b. Fibrosis pulmonar
c. Edema pulmonar
d. Neumoconiosis
e. Neumonía por mycoplasma

Respuesta propuesta: b. Fibrosis pulmonar

La prueba de origen no traía la respuesta ni la explicación; la alternativa indicada es una propuesta y no proviene del curso.

Fuente: Respiratorio, prueba 6 (captura), P18

Cáncer pulmonar y nódulo pulmonar solitario (7)

64. Un paciente de 60 años, fumador, se realiza una radiografía de tórax, como parte del control de su empresa, que demuestra la presencia de un nódulo pulmonar de 3 cm de diámetro, ubicado en la zona parahiliar izquierda. Se solicita un TAC de tórax que muestra un tumor redondo, sólido, con bordes espiculados. La conducta más adecuada es:

a. Solicitar nueva radiografía en 3 meses
b. Realizar broncoscopía y biopsia
c. Realizar resección quirúrgica
d. Indicar tratamiento antibiótico y controlar en 2 semanas, con nueva radiografía
e. Solicitar baciloscopías de esputo y cultivo para mycobacterias

Respuesta propuesta: b. Realizar broncoscopía y biopsia

La prueba de origen no traía la respuesta ni la explicación; la alternativa indicada es una propuesta y no proviene del curso.

Fuente: Respiratorio, prueba 1 (captura), P8

65. Un paciente de 68 años, fumador de 20 cigarrillos al día, consulta por disnea y tos con expectoración de un mes de evolución. Al examen físico se aprecia hipocratismo digital, con uñas en vidrio de reloj. Su examen pulmonar no muestra alteraciones. La conducta inicial más adecuada es:

a. Solicitar espirometría
b. Solicitar radiografía pulmonar
c. Solicitar lavado broncoalveolar
d. Solicitar TAC de pulmón
e. Solicitar broncoscopia

Respuesta correcta: b. Solicitar radiografía pulmonar

Explicación: La sospecha es un cáncer de pulmón: fumador con disnea y tos inespecífica, más hipocratismo digital; que el examen pulmonar sea normal, es algo muy frecuente en el cáncer. Si bien el TAC de tórax es el mejor examen para evaluar un nódulo pulmonar solitario, el primer examen sigue siendo la radiografía de tórax. Además, se pregunta explícitamente la conducta inicial.

Fuente: Respiratorio, prueba 2 (captura), P9

66. Un paciente de 68 años, fumador de 30 paquetes-año consulta por malestar general y tos con expectoración, la que suele ser hemoptoica. Se solicita una radiografía de tórax, que muestra un nódulo

pulmonar de 4,5 cm de diámetro, el que se confirma con el TAC, ubicado en el lóbulo superior izquierdo. La conducta más adecuada es:

a. Solicitar broncoscopía
b. Solicitar RMN de tórax
c. Solicitar angioTAC de tórax
d. Iniciar clindamicina endovenosa
e. Realizar lobectomía pulmonar superior izquierda

Respuesta propuesta: a. Solicitar broncoscopía

La prueba de origen no traía la respuesta ni la explicación; la alternativa indicada es una propuesta y no proviene del curso.

Fuente: Respiratorio, prueba 3 (captura), P5

67. Un paciente de 60 años, sintomático, se realiza una radiografía de tórax, como parte de un chequeo médico, que detecta un nódulo pulmonar solitario de 3 cm de diámetro en el lóbulo superior derecho. No cuenta con radiografías previas y su examen físico es normal. La conducta más adecuada es:

a. Controlar con nueva radiografía de tórax en 3 meses
b. Controlar con nueva radiografía de tórax en 6 meses
c. Controlar con nueva radiografía de tórax en 12 meses
d. Solicitar un TAC de tórax
e. Realizar biopsia excisional

Respuesta propuesta: d. Solicitar un TAC de tórax

La prueba de origen no traía la respuesta ni la explicación; la alternativa indicada es una propuesta y no proviene del curso.

Fuente: Respiratorio, prueba 4 (captura), P3

68. ¿Qué histología del cáncer pulmonar se asocia más frecuentemente a un síndrome paraneoplásico?

a. Espinocelular
b. Células pequeñas
c. Adenocarcinoma
d. Carcinoma bronquioloalveolar
e. Células grandes

Respuesta propuesta: b. Células pequeñas

La prueba de origen no traía la respuesta ni la explicación; la alternativa indicada es una propuesta y no proviene del curso.

Fuente: Respiratorio, prueba 5 (captura), P20

69. Un paciente de 60 años, que fuma una cajetilla al día, presenta un cuadro de tos con expectoración, de un mes de evolución, asociado a disnea ocasional. Además, ha presentado hemoptisis en una oportunidad. El diagnóstico más probable es:

a. Bronquiectasias
b. Bronquitis crónica
c. Tuberculosis pulmonar
d. Cáncer bronquial
e. Neumonía por Haemophilus influenzae

Respuesta propuesta: d. Cáncer bronquial

La prueba de origen no traía la respuesta ni la explicación; la alternativa indicada es una propuesta y no proviene del curso.

Fuente: Respiratorio, prueba 6 (captura), P8

70. Un paciente de 65 años, fumador importante, presenta un nódulo pulmonar de 3 cms, de bordes espiculados, localizado en el lóbulo medio derecho, diagnosticado como hallazgo en una radiografía de tórax que se realizó como parte del control de rutina de su trabajo. El examen físico es normal. La conducta inicial más adecuada es:

a. Resolver quirúrgicamente
b. Iniciar quimioterapia y radioterapia
c. Solicitar biopsia por broncoscopía
d. Solicitar TAC de tórax
e. Revisar las radiografías previas

Respuesta propuesta: e. Revisar las radiografías previas

La prueba de origen no traía la respuesta ni la explicación; la alternativa indicada es una propuesta y no proviene del curso.

Fuente: Respiratorio, prueba 6 (captura), P19

Insuficiencia respiratoria, gases arteriales y distrés (10)

71. Un paciente presenta los siguientes gases arteriales: PaO2: 50 mmHg, PaCO2: 60 mmHg, pH: 7,28, HCO3: 27. Su diagnóstico es:

a. Gases venosos
b. Insuficiencia respiratoria parcial, con acidosis metabólica
c. Insuficiencia respiratoria parcial, con acidosis metabólica y respiratoria
d. Insuficiencia respiratoria global, con acidosis respiratoria
e. Insuficiencia respiratoria global, con acidosis respiratoria y metabólica

Respuesta propuesta: d. Insuficiencia respiratoria global, con acidosis respiratoria

La prueba de origen no traía la respuesta ni la explicación; la alternativa indicada es una propuesta y no proviene del curso.

Fuente: Respiratorio, prueba 1 (captura), P6

72. Un paciente sufre quemaduras del 35% del cuerpo, producto de un incendio que afectó su casa. Las zonas más comprometidas son las extremidades inferiores y el tronco, sin compromiso de la cara. Es hospitalizado en la unidad de cuidados intensivos y recibe analgésicos y reposición de volumen con coloides y cristaloides. Dos días después evoluciona con dificultad respiratoria grave, con saturación arterial de 70% a FIO2 ambiental, que mejora a 85% con O2 al 100%. El diagnóstico más probable es:

a. Neumonía
b. Atelectasia masiva
c. Quemadura de la vía respiratoria
d. Distrés respiratorio
e. Tromboembolismo pulmonar masivo

Respuesta correcta: d. Distrés respiratorio

Explicación: Es un distrés respiratorio clásico, en este caso secundario al SIRS (síndrome de respuesta inflamatoria sistémica), debido a las quemaduras. Tiene una PaO2/FiO2 de 85, que es muy baja (85/1). Se debe solicitar una radiografía de tórax e iniciar oxígeno, más ventilación mecánica a presión positiva, más el tratamiento de la causa de base. La quemadura de la vía respiratoria, se ve inmediatamente después de la quemadura (no dos días después), como un cuadro de dolor, obstrucción alta y hemoptisis.

Fuente: Respiratorio, prueba 2 (captura), P8

73. Un paciente presenta los siguientes gases arteriales: PaO2: 50 mmHg, PaCO2: 60 mmHg, pH: 7,24, HCO3: 25. ¿Cuál es el diagnóstico?

a. Insuficiencia respiratoria global con acidosis metabólica
b. Insuficiencia respiratoria parcial con acidosis metabólica
c. Insuficiencia respiratoria global con acidosis respiratoria
d. Insuficiencia respiratoria parcial con acidosis respiratoria
e. Error en la toma de muestra, con gases venosos en lugar de arteriales

Respuesta propuesta: c. Insuficiencia respiratoria global con acidosis respiratoria

La prueba de origen no traía la respuesta ni la explicación; la alternativa indicada es una propuesta y no proviene del curso.

Fuente: Respiratorio, prueba 3 (captura), P16

74. Un paciente cursando una neumonía grave, presenta los siguientes gases arteriales: PaO2: 55 mmHg, PaCO2: 58 mmHg, pH: 7,28. El diagnóstico gasométrico es:

a. Insuficiencia respiratoria global con acidosis respiratoria
b. Insuficiencia respiratoria parcial con acidosis respiratoria
c. Insuficiencia respiratoria global con acidosis metabólica
d. Insuficiencia respiratoria parcial con acidosis metabólica
e. Error de la muestra, con toma de gases venosos

Respuesta propuesta: a. Insuficiencia respiratoria global con acidosis respiratoria

La prueba de origen no traía la respuesta ni la explicación; la alternativa indicada es una propuesta y no proviene del curso.

Fuente: Respiratorio, prueba 4 (captura), P2

75. El distrés respiratorio del adulto se produce por:

a. Aumento de la presión de la arteria pulmonar
b. Aumento de la presión hidrostática a nivel capilar pulmonar
c. Aumento de la presión oncótica a nivel capilar pulmonar
d. Aumento de la presión oncótica intersticial
e. Aumento de la permeabilidad capilar pulmonar

Respuesta propuesta: e. Aumento de la permeabilidad capilar pulmonar

La prueba de origen no traía la respuesta ni la explicación; la alternativa indicada es una propuesta y no proviene del curso.

Fuente: Respiratorio, prueba 4 (captura), P15

76. El distrés respiratorio del adulto requiere para su diagnóstico la presencia de:

a. Presión arterial menor a 140/90 mmHg
b. Ausencia de hipertensión pulmonar
c. Presión capilar pulmonar menor a 18 mmHg
d. Ausencia de patologías pulmonares de base
e. Normalidad de la Pa/Fi (cociente entre la presión arterial de oxígeno y la fracción inspirada de oxígeno)

Respuesta propuesta: c. Presión capilar pulmonar menor a 18 mmHg

La prueba de origen no traía la respuesta ni la explicación; la alternativa indicada es una propuesta y no proviene del curso.

Fuente: Respiratorio, prueba 5 (captura), P4

77. Identifique la asociación CORRECTA entre la patología y el mecanismo de hipoxemia:

a. Alteración neuromuscular - Trastorno V/Q
b. Neumonía - Shunt
c. EPOC - Trastorno de la Difusión
d. Fibrosis pulmonar - Hipoventilación
e. Tromboembolismo pulmonar - Shunt

Respuesta propuesta: b. Neumonía - Shunt

La prueba de origen no traía la respuesta ni la explicación; la alternativa indicada es una propuesta y no proviene del curso.

Fuente: Respiratorio, prueba 5 (captura), P8

78. Se obtienen los siguientes gases arteriales PaO2: 80 mmHg, PaCO2: 30 mmHg, pH: 7.47, HCO3: 21 mmol/l. ¿A qué estado ácido base corresponden?

a. Alcalosis respiratoria
b. Alcalosis metabólica
c. Acidosis respiratoria con alcalosis metabólica
d. Alcalosis mixta
e. Gases venosos

Respuesta propuesta: a. Alcalosis respiratoria

La prueba de origen no traía la respuesta ni la explicación; la alternativa indicada es una propuesta y no proviene del curso.

Fuente: Respiratorio, prueba 5 (captura), P19

79. ¿Cuál de las siguientes alternativas es más sugerente de una acidosis respiratoria pura?

a. pH bajo, CO2 alto, Bicarbonato normal-alto
b. pH bajo, CO2 alto, Bicarbonato bajo
c. pH bajo, CO2 bajo, Bicarbonato alto
d. pH bajo, CO2 bajo, Bicarbonato bajo
e. pH alto, CO2 alto, Bicarbonato alto

Respuesta propuesta: a. pH bajo, CO2 alto, Bicarbonato normal-alto

La prueba de origen no traía la respuesta ni la explicación; la alternativa indicada es una propuesta y no proviene del curso.

Fuente: Respiratorio, prueba 6 (captura), P6

80. ¿Cuál de los siguientes datos NO aparece en el síndrome de insuficiencia (distress) respiratoria aguda del adulto, plenamente establecido e inducido por politraumatismo?

a. Presión capilar pulmonar (PCP) de enclavamiento superior a 20 mm Hg.
b. Infiltrados alveolares difusos en la radiología torácica.
c. Hipoxemia por aumento del shunt intrapulmonar.
d. Hipertensión pulmonar.
e. Disminución de la distensibilidad ("compliance") pulmonar.

Respuesta propuesta: a. Presión capilar pulmonar (PCP) de enclavamiento superior a 20 mm Hg.

La prueba de origen no traía la respuesta ni la explicación; la alternativa indicada es una propuesta y no proviene del curso.

Fuente: Respiratorio, prueba 6 (captura), P20

Trauma torácico y neumotórax (7)

81. Paciente de 20 años, consulta por dolor torácico de inicio súbito, con tope inspiratorio, asociado a disnea leve. El examen físico sólo demuestra una leve asimetría en la intensidad del murmullo pulmonar entre ambos hemicampos pulmonares. El diagnóstico más probable y la conducta a seguir son respectivamente:

a. Tromboembolismo pulmonar y solicitar angioTAC de tórax
b. Neumonía y administrar antibióticos
c. Neumotórax hipertensivo e instalar toracostomía
d. Neumotórax espontáneo y solicitar radiografía de tórax
e. Tromboembolismo pulmonar e iniciar anticoagulación

Respuesta propuesta: d. Neumotórax espontáneo y solicitar radiografía de tórax

La prueba de origen no traía la respuesta ni la explicación; la alternativa indicada es una propuesta y no proviene del curso.

Fuente: Respiratorio, prueba 1 (captura), P20

82. Un paciente sufre un traumatismo de tórax, con fracturas costales segmentarias que dejan una parte del tórax que se mueve de manera independiente al resto de la pared torácica. Además evoluciona con dificultad respiratoria y desaturación arterial de 80%, a pesar de administrar oxígeno. La radiografía de tórax es compatible con una contusión pulmonar izquierda, sin neumotórax ni derrame pleural. La conducta más adecuada es:

a. Realizar resolución quirúrgica de inmediato y brindar soporte respiratorio
b. Conectar al ventilador mecánico, con presión de ventilación positiva e iniciar analgésicos endovenosos
c. Iniciar oxígeno al 100% y realizar nebulizaciones con salbutamol
d. Conectar a BiPAP e instalar tubo pleural con trampa de agua
e. Solicitar videotoracoscopía de urgencia e iniciar analgésicos y soporte respiratorio

Respuesta propuesta: b. Conectar al ventilador mecánico, con presión de ventilación positiva e iniciar analgésicos endovenosos

La prueba de origen no traía la respuesta ni la explicación; la alternativa indicada es una propuesta y no proviene del curso.

Fuente: Respiratorio, prueba 3 (captura), P9

83. Un paciente de 20 años presenta dolor torácico tipo puntada de costado, que inició hace 2 horas, sin otros síntomas. Al examen físico está en buenas condiciones generales, con signos vitales normales y saturación arterial de 98%. Se solicita radiografía de tórax, que muestra un neumotórax pequeño, que solo se ve en el ápice izquierdo, de 1 cm de ancho. La conducta más adecuada es:

a. Administrar analgésicos y observar por 4-6 horas, controlando con nueva radiografía de tórax
b. Puncionar el segundo espacio intercostal de manera urgente
c. Instalar tubo pleural de inmediato
d. Solicitar un TAC de tórax
e. Resolver quirúrgicamente de inmediato

Respuesta propuesta: a. Administrar analgésicos y observar por 4-6 horas, controlando con nueva radiografía de tórax

La prueba de origen no traía la respuesta ni la explicación; la alternativa indicada es una propuesta y no proviene del curso.

Fuente: Respiratorio, prueba 3 (captura), P13

84. Un paciente de 45 años sufre un accidente de tránsito con golpe en el tórax. Evoluciona con dificultad respiratoria y al examen físico se constata abolición del murmullo pulmonar izquierdo, con matidez a la percusión de dicho campo pulmonar. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

a. Contusión pulmonar
b. Neumotórax
c. Distrés respiratorio
d. Hemotórax
e. Lesión traqueobronquial

Respuesta propuesta: d. Hemotórax

La prueba de origen no traía la respuesta ni la explicación; la alternativa indicada es una propuesta y no proviene del curso.

Fuente: Respiratorio, prueba 3 (captura), P14

85. Un paciente de 20 años consulta por dolor tipo puntada de costado derecho. Se solicita radiografía de tórax, que muestra un neumotórax del 50% del campo pulmonar derecho. La conducta más adecuada es:

a. Administrar analgésicos intravenosos y controlar con una nueva radiografía en 6 horas
b. Puncionar el segundo espacio intercostal en la línea media clavicular
c. Instalar una sonda pleural, conectada a trampa de agua
d. Realizar ventilación mecánica no invasiva
e. Resolver quirúrgicamente

Respuesta propuesta: c. Instalar una sonda pleural, conectada a trampa de agua

La prueba de origen no traía la respuesta ni la explicación; la alternativa indicada es una propuesta y no proviene del curso.

Fuente: Respiratorio, prueba 4 (captura), P14

86. Un paciente sufre un accidente de tránsito, resultando con un golpe en el tórax. Evoluciona con disnea y caída de la saturación arterial de oxígeno. Al examen físico se auscultan crepitaciones difusas bilaterales y la radiografía de tórax muestra infiltrados pulmonares de tipo alveolar, en distintas zonas de los pulmones. El diagnóstico más probable es:

a. Hemotórax
b. Lesión traqueal
c. Neumonía
d. Contusión pulmonar
e. Tromboembolismo pulmonar

Respuesta propuesta: d. Contusión pulmonar

La prueba de origen no traía la respuesta ni la explicación; la alternativa indicada es una propuesta y no proviene del curso.

Fuente: Respiratorio, prueba 4 (captura), P19

87. Acude a urgencias un paciente de 20 años, con un cuadro sugerente de un neumotórax espontáneo. Además tiene antecedente de haber sufrido uno, el año pasado, el que fue manejado con pleurocentesis. Se solicita una radiografía de tórax, que confirma el diagnóstico, demostrando la presencia de un neumotórax derecho, del 30% del campo pulmonar. La conducta más adecuada es:

a. Administrar analgésicos y observar evolución por 4 a 6 horas, controlando con una nueva radiografía de tórax
b. Realizar aspiración con jeringa y llave de 3 pasos
c. Iniciar analgesia e instalar un tubo pleural con trampa de agua, sin necesidad de cirugía

d. Conectar a ventilación mecánica con presión positiva
e. Resolver quirúrgicamente

Respuesta propuesta: e. Resolver quirúrgicamente

La prueba de origen no traía la respuesta ni la explicación; la alternativa indicada es una propuesta y no proviene del curso.

Fuente: Respiratorio, prueba 5 (captura), P16

Tromboembolismo pulmonar (2)

88. Un paciente de 68 años, presenta un cuadro de baja de peso y constipación de 2 meses de evolución, el que ha tratado con aumento de fibra en la dieta, sin lograr mejoría. Acude al servicio de urgencia por un cuadro de inicio súbito de disnea y dolor torácico de tipo puntada en el lado derecho. Al examen físico está sudoroso, taquipneico y taquicárdico, sin otras alteraciones. Satura 89% a FIO2 ambiental y la radiografía de tórax solo muestra un derrame pleural pequeño en el ángulo costofrénico derecho. La conducta más adecuada es:

a. Iniciar antibióticos endovenosos y oxígeno
b. Solicitar dímero D e iniciar oxígeno
c. Solicitar angioTAC de tórax e iniciar oxígeno
d. Instalar un tubo pleural y brindar soporte ventilatorio con BiPAP
e. Conectar a ventilación mecánica

Respuesta propuesta: c. Solicitar angioTAC de tórax e iniciar oxígeno

La prueba de origen no traía la respuesta ni la explicación; la alternativa indicada es una propuesta y no proviene del curso.

Fuente: Respiratorio, prueba 3 (captura), P19

89. Un paciente de 30 años presenta un cuadro de disnea de inicio súbito. Al examen físico está angustiado, en buenas condiciones, con FR: 20x', saturación arterial 99% a FIO2 ambiental, presión arterial 120/80 mmHg, FC: 70x'. Su examen cardiopulmonar muestra un RR2T sin soplos y MP(+), sin ruidos agregados. Se solicita una radiografía de tórax, que resulta normal y niveles plasmáticos de dímero D, que resultan normales. La conducta más adecuada es:

a. Iniciar anticoagulación con heparina
b. Iniciar trombolisis con activador tisular del plasminógeno, recombinante (rTPA)
c. Solicitar ecografía doppler de extremidades inferiores
d. Solicitar angiografía pulmonar
e. Descartar el diagnóstico de TEP

Respuesta propuesta: e. Descartar el diagnóstico de TEP

La prueba de origen no traía la respuesta ni la explicación; la alternativa indicada es una propuesta y no proviene del curso.

Fuente: Respiratorio, prueba 4 (captura), P18

Bronquiectasias (2)

90. Un paciente de 40 años, sin antecedentes ni hábitos de importancia, sufre una neumonía en el lóbulo inferior izquierdo, la que fue tratada con antibióticos, con buena respuesta. Sin embargo, evoluciona posteriormente con broncorrea crónica, mayor en las mañanas, que en ocasiones viene acompañada de expectoración hemoptoica. El diagnóstico más probable es:

a. Cuerpo extraño bronquial

b. Tuberculosis
c. Cáncer pulmonar
d. Bronquitis crónica
e. Bronquiectasias

Respuesta propuesta: e. Bronquiectasias

La prueba de origen no traía la respuesta ni la explicación; la alternativa indicada es una propuesta y no proviene del curso.

Fuente: Respiratorio, prueba 5 (captura), P12

91. Las bronquiectasias se diagnostican con:

a. La clínica
b. La radiografía de tórax
c. La tomografía axial computada de tórax
d. La broncoscopía
e. La biopsia pulmonar

Respuesta propuesta: c. La tomografía axial computada de tórax

La prueba de origen no traía la respuesta ni la explicación; la alternativa indicada es una propuesta y no proviene del curso.

Fuente: Respiratorio, prueba 6 (captura), P10

Infecciones de la vía aérea superior (5)

92. Un paciente de 13 años presenta un cuadro de odinofagia, asociada a malestar general y tos seca de 2 días de evolución. Al examen físico presenta faringe eritematosa, sin exudado, se palpan algunas adenopatías cervicales y su examen pulmonar es normal. La conducta más adecuada es:

a. Iniciar con tratamiento sintomático
b. Iniciar amoxicilina oral
c. Iniciar levofloxacino oral
d. Iniciar oseltamivir oral
e. Iniciar ceftriaxona oral

Respuesta propuesta: a. Iniciar con tratamiento sintomático

La prueba de origen no traía la respuesta ni la explicación; la alternativa indicada es una propuesta y no proviene del curso.

Fuente: Respiratorio, prueba 1 (captura), P7

93. El tratamiento de primera línea de una sinusitis bacteriana aguda es:

a. Amoxicilina
b. Clindamicina
c. Cloxacilina
d. Amoxicilina + ácido clavulánico
e. Levofloxacino

Respuesta propuesta: a. Amoxicilina

La prueba de origen no traía la respuesta ni la explicación; la alternativa indicada es una propuesta y no proviene del curso.

Fuente: Respiratorio, prueba 1 (captura), P16

94. Un niño de 8 años consulta por fiebre y odinofagia intensa que inició hace 24 horas y que le impide tragar. No ha presentado otros síntomas y al examen físico se aprecia febril hasta 40 °C, con gran eritema faríngeo, con algunas petequias y exudado grisáceo en ambas amígdalas. Además se palpan varias adenopatías cervicales anteriores, dolorosas a la palpación. El agente etiológico más probable es:

a. Neumococo
b. Rinovirus
c. Virus influenza
d. Streptococcus pyogenes
e. Virus de Ebstein Baar

Respuesta propuesta: d. Streptococcus pyogenes

La prueba de origen no traía la respuesta ni la explicación; la alternativa indicada es una propuesta y no proviene del curso.

Fuente: Respiratorio, prueba 3 (captura), P10

95. Un paciente consulta por un cuadro de 2 días de evolución de rinorrea abundante, asociada a estornudos y malestar general. Además, ha presentado fiebre hasta 38 °C, sensación de descarga posterior, hiposmia y obstrucción nasal. El examen físico sólo muestra rinorrea mucosa y eritema faríngeo, sin otras alteraciones. La conducta más adecuada es:

a. Indicar tratamiento sintomático
b. Solicitar TAC de cavidades paranasales
c. Iniciar amoxicilina oral
d. Iniciar amoxicilina + ácido clavulánico oral
e. Solicitar nasofibroscopía

Respuesta propuesta: a. Indicar tratamiento sintomático

La prueba de origen no traía la respuesta ni la explicación; la alternativa indicada es una propuesta y no proviene del curso.

Fuente: Respiratorio, prueba 5 (captura), P5

96. Paciente de 21 años, previamente sano, inicia fiebre, malestar general, cefalea y rinorrea purulenta. Refiere además disminución del olfato y obstrucción nasal izquierda. Al examen físico sólo se aprecia faringe eritematosa, sin exudado. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

a. Cuerpo extraño nasal
b. Amigdalitis aguda estreptocócica
c. Neumonía
d. Gripe
e. Sinusitis aguda

Respuesta propuesta: e. Sinusitis aguda

La prueba de origen no traía la respuesta ni la explicación; la alternativa indicada es una propuesta y no proviene del curso.

Fuente: Respiratorio, prueba 6 (captura), P16

Patología respiratoria pediátrica y neonatal (9)

97. Un recién nacido de 30 semanas de edad gestacional, presenta un cuadro de dificultad respiratoria importante, a las pocas horas de nacer, que satura 90% a FIO2 del 30%. Al examen físico se auscultan crepitaciones en ambos pulmones. El diagnóstico más probable es:

a. Enfermedad de membrana hialina

b. Síndrome de aspiración meconial
c. Taquipnea transitoria
d. Neumonía por Streptococcus agalactiae
e. Bronquiolitis por VRS

Respuesta propuesta: a. Enfermedad de membrana hialina

La prueba de origen no traía la respuesta ni la explicación; la alternativa indicada es una propuesta y no proviene del curso.

Fuente: Respiratorio, prueba 1 (captura), P9

98. Un niño de 2 años presenta tos de inicio súbito intensa, persistiendo con tos, asociada a expectoración mucopurulenta durante los días subsiguientes. Al examen físico se auscultan estertores y sibilancias localizadas en la base derecha. El diagnóstico más probable es:

a. Neumonía
b. Bronconeumonía
c. Tromboembolismo pulmonar
d. Coqueluche
e. Cuerpo extraño bronquial

Respuesta propuesta: e. Cuerpo extraño bronquial

La prueba de origen no traía la respuesta ni la explicación; la alternativa indicada es una propuesta y no proviene del curso.

Fuente: Respiratorio, prueba 1 (captura), P12 · Respiratorio, prueba 6 (captura), P12

99. Un paciente de 14 años consulta por disnea y malestar general, asociado a tos frecuente. Refiere que hace 15 días inició un cuadro catarral, con rinorrea y tos y que esta última fue aumentando, agregándose disnea de esfuerzo en el último tiempo. Al examen físico se auscultan algunas sibilancias y crepitaciones difusas. La radiografía de tórax muestra engrosamientos peribronquiales y un patrón alveolointersticial. El tratamiento más adecuado es:

a. Amoxicilina
b. Ceftriaxona
c. Levofloxacino
d. Broncodilatadores + corticoides
e. Amoxicilina + ácido clavulánico

Respuesta propuesta: d. Broncodilatadores + corticoides

La prueba de origen no traía la respuesta ni la explicación; la alternativa indicada es una propuesta y no proviene del curso.

Fuente: Respiratorio, prueba 3 (captura), P1

100. Un recién nacido postérmino, presenta un cuadro de dificultad respiratoria grave, con saturación arterial de 85% a FIO2 ambiental y aleteo nasal. Al examen físico se auscultan sibilancias bilaterales y se aprecia signos de hiperinsuflación pulmonar. El diagnóstico más probable es:

a. Enfermedad de membrana hialina
b. Hernia diafragmática congénita
c. Taquipnea transitoria
d. Síndrome de aspiración meconial
e. Cardiopatía congénita

Respuesta propuesta: d. Síndrome de aspiración meconial

La prueba de origen no traía la respuesta ni la explicación; la alternativa indicada es una propuesta y no proviene del curso.

Fuente: Respiratorio, prueba 3 (captura), P3

101. Un niño de 2 años presenta un cuadro de fiebre hasta 41 °C y malestar general marcado, asociado a tos disfónica y dificultad para respirar. Al examen físico está en malas condiciones generales, presenta estridor inspiratorio, uso de musculatura accesoria y se inclina hacia atrás para poder respirar. El diagnóstico más probable es:

a. Laringitis obstructiva
b. Bronquiolitis aguda
c. Neumonía
d. Coqueluche
e. Epiglotitis bacteriana

Respuesta propuesta: e. Epiglotitis bacteriana

La prueba de origen no traía la respuesta ni la explicación; la alternativa indicada es una propuesta y no proviene del curso.

Fuente: Respiratorio, prueba 4 (captura), P6

102. Un paciente de 7 años presenta un cuadro de tos con expectoración mucosa de 15 días de evolución, que ha ido en aumento, hasta asociarse a disnea. Al examen físico se auscultan sibilancias bilaterales espiratorias y crepitaciones difusas, mayores en las bases. Su hermana de 14 años está con síntomas similares. El tratamiento para la patología descrita es:

a. Amoxicilina
b. Azitromicina
c. Ciprofloxacino
d. Amoxicilina más ácido clavulánico
e. Sintomático

Respuesta propuesta: b. Azitromicina

La prueba de origen no traía la respuesta ni la explicación; la alternativa indicada es una propuesta y no proviene del curso.

Fuente: Respiratorio, prueba 4 (captura), P9

103. Un recién nacido de 36 semanas de edad gestacional, presenta taquipnea y quejido al nacer. Al examen físico presenta crepitaciones pulmonares escasas y satura 90%, normalizándose con O2 al 28%. El diagnóstico más probable es:

a. Enfermedad de membrana hialina
b. Hipertensión pulmonar persistente
c. Síndrome de aspiración de meconio
d. Taquipnea transitoria del recién nacido
e. Neumonía neonatal

Respuesta propuesta: d. Taquipnea transitoria del recién nacido

La prueba de origen no traía la respuesta ni la explicación; la alternativa indicada es una propuesta y no proviene del curso.

Fuente: Respiratorio, prueba 5 (captura), P6

104. Un niño de 3 años presenta un cuadro de dificultad respiratoria, asociado a estridor inspiratorio. La madre refiere que el día de ayer comenzó con fiebre hasta 38 °C, disfonía y tos disfónica. No presentó

mayor compromiso del estado general, pero que desde hace 20 minutos se le agregó disnea y respiración ruidosa. El agente etiológico más probable es:

a. Virus respiratorio sincicial
b. Virus influenza
c. Virus parainfluenza
d. Neumococo
e. Haemophilus influenzae

Respuesta propuesta: c. Virus parainfluenza

La prueba de origen no traía la respuesta ni la explicación; la alternativa indicada es una propuesta y no proviene del curso.

Fuente: Respiratorio, prueba 5 (captura), P10

105. Un recién nacido de 40 semanas de edad gestacional, presenta un cuadro de dificultad respiratoria importante, a las pocas horas de nacer. Su líquido amniótico mostraba meconio. Al examen físico se auscultan crepitaciones y sibilancias en ambos pulmones, asociada a espiración prolongada y aumento del diámetro anteroposterior. El diagnóstico más probable es:

a. Enfermedad de membrana hialina
b. Síndrome de aspiración meconial
c. Taquipnea transitoria
d. Neumonía por Streptococcus agalactiae
e. Bronquiolitis por VRS

Respuesta propuesta: b. Síndrome de aspiración meconial

La prueba de origen no traía la respuesta ni la explicación; la alternativa indicada es una propuesta y no proviene del curso.

Fuente: Respiratorio, prueba 6 (captura), P9

Semiología y pruebas funcionales respiratorias (4)

106. ¿Qué examen es el más adecuado para diferenciar la disnea de origen respiratorio de la disnea de origen cardíaca?

a. Péptido natriurético cerebral
b. Electrocardiograma
c. Radiografía de tórax
d. Angiografía pulmonar
e. Test de esfuerzo

Respuesta correcta: a. Péptido natriurético cerebral

Explicación: Lo más importante es la clínica, ya que los antecedentes y síntomas orientan mucho a una causa u otra. Sin embargo, si persiste la duda, o hay concomitancia de causas (ej. tiene EPOC y una cardiopatía), el BNP (brain natriuretic peptid) es un examen muy útil para hacer la diferencia. Si está elevado, es muy sugerente de insuficiencia cardíaca. Si está normal, en cambio, es una disnea respiratoria.

Fuente: Respiratorio, prueba 2 (captura), P4

107. Para calcular los valores teóricos (valores esperados) para la espirometría se utilizan los siguientes datos, EXCEPTO:

a. Peso del paciente

b. Talla del paciente
c. Sexo del paciente
d. Raza del paciente
e. Edad del paciente

Respuesta correcta: a. Peso del paciente

Explicación: Los valores esperados de la espirometría se determinan en base al sexo, edad y talla. Además en los países con diferenciación de razas (en Chile casi todos somos mestizos) hay tablas para las distintas razas. El peso, sin embargo, no tiene correlación con los valores espirométricos.

Fuente: Respiratorio, prueba 2 (captura), P5

108. La asociación de matidez, crepitaciones y broncofonía, en un lóbulo pulmonar, sugiere un(a):

a. Derrame pleural
b. Neumotórax
c. Neumonía
d. Cuerpo extraño
e. Atelectasia

Respuesta propuesta: c. Neumonía

La prueba de origen no traía la respuesta ni la explicación; la alternativa indicada es una propuesta y no proviene del curso.

Fuente: Respiratorio, prueba 4 (captura), P13

109. La asociación de dolor tipo puntada de costado, disminución del murmullo pulmonar e hipersonoridad a la percusión torácica es característica de:

a. Tromboembolismo pulmonar
b. Neumonía
c. Neumotórax
d. Atelectasia
e. Cuerpo extraño bronquial

Respuesta propuesta: c. Neumotórax

La prueba de origen no traía la respuesta ni la explicación; la alternativa indicada es una propuesta y no proviene del curso.

Fuente: Respiratorio, prueba 5 (captura), P7

Gastroenterología (70)

Esófago y reflujo gastroesofágico (6)

1. Un paciente de 45 años, diagnosticado de reflujo gastroesofágico hace 10 años, en tratamiento con lansoprazol oral una vez al día, consulta porque desde hace un mes sus síntomas recurrieron, presentando pirosis intensa y frecuente, a pesar de que no ha discontinuado su uso. Su examen físico es normal. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

a. Duplicar la dosis diaria de lansoprazol, indicándolo dos veces al día
b. Solicitar pH-metría esofágica
c. Reemplazar el lansoprazol por esomeprazol
d. Realizar endoscopía digestiva alta
e. Reforzar medidas no farmacológicas, como levantar la cabecera de la cama y evitar comer y consumir alcohol antes de dormir

Respuesta correcta: d. Realizar endoscopía digestiva alta

Explicación: Tiene un signo de alarma: el cambio en los síntomas (recordar el ABCDEFGH-N completo), por lo que lo primero es descartar una complicación (ej. cáncer), con la endoscopía digestiva alta.

Fuente: Gastroenterología, prueba 4 del 21 de abril de 2024, P1

2. Un paciente de 30 años presenta pirosis con frecuencia, en especial después de algunas comidas. Además, refiere regurgitación ácida de alimentos. Se solicita una endoscopía digestiva alta, que resulta normal. La conducta más adecuada es:

a. Indicar medidas generales antirreflujo y esomeprazol oral
b. Solicitar manometría esofágica
c. Iniciar tratamiento erradicador de Helicobacter pylori
d. Solicitar radiografías baritadas
e. Diagnosticar una dispepsia funcional y realizar educación del paciente

Respuesta correcta: a. Indicar medidas generales antirreflujo y esomeprazol oral

Explicación: Tiene clínica de reflujo gastroesofágico (RGE): pirosis más regurgitación. Por tanto, tiene el diagnóstico de reflujo, ya que el diagnóstico es predominantemente clínico. La endoscopía normal no descarta el diagnóstico, y es más, no debió haberse pedido, ya que no había signos de alarma. La manometría es el examen diagnóstico de la acalasia. La erradicación es el tratamiento de la úlcera. Las radiografías baritadas sirven para el diagnóstico de divertículos esofágicos y pueden ser de utilidad en la acalasia y en la disfagia en general. La dispepsia funcional tiene epigastralgia y no pirosis ni regurgitación.

Fuente: Gastroenterología, prueba 1 del 21 de abril de 2024, P6

3. Un paciente de 58 años consulta por disfagia de localización alta, que inició hace 1 año, que ha ido en aumento y en ocasiones se acompaña de regurgitación de alimentos no ácidos. Además, presenta halitosis y ha presentado 2 neumonías en ese tiempo. El examen físico es normal. El diagnóstico más probable es:

a. Esófago de Barret
b. Cáncer de estómago
c. Cáncer de esófago
d. Divertículo de Zenker
e. Acalasia esofágica

Respuesta correcta: d. Divertículo de Zenker

Explicación: Es la clínica clásica del divertículo de Zenker: disfagia alta (también llamada disfagia orofaríngea), generalmente ilógica (ya que varía según está más o menos lleno el divertículo) + halitosis + regurgitación no ácida (no alcanza a llegar al estómago) + neumonías. Su diagnóstico se realiza con radiografías baritadas. El tratamiento es quirúrgico (excepto en asintomáticos muy pequeños >1 cm). - El esófago de Barret es asintomático. - El cáncer de estómago puede presentarse de varias formas, pero si hace disfagia, es de localización baja. - El cáncer de esófago puede tener una clínica similar, pero por regla general solo tiene disfagia lógica progresiva.

Fuente: Gastroenterología, prueba 3 del 21 de abril de 2024, P6

4. Un paciente de 65 años consulta por disfagia, de 3 meses de evolución, que le dificulta tragar elementos sólidos de gran tamaño, pero que ha ido progresando, por lo que actualmente también tiene dificultad para tragar alimentos sólidos de tamaño menor. Su examen físico no muestra alteraciones. La conducta más adecuada es:

a. Solicitar manometría esofágica
b. Solicitar radiografías baritadas
c. Solicitar endoscopía digestiva alta
d. Solicitar pH-metría de 24 horas
e. Indicar erradicación de Helicobacter pylori

Respuesta correcta: c. Solicitar endoscopía digestiva alta

Explicación: Tiene una disfagia de tipo lógica, dado que afecta a sólidos y va progresando a alimentos de menor tamaño. Es característica del cáncer de esófago y otros procesos estenóticos (siendo el cáncer lo más probable). La disfagia lógica se estudia con endoscopía, por lo mismo. - La manometría es el examen de la acalasia, es decir, el estudio de la disfagia ilógica (que afecta a líquidos más que a sólidos y que suele ser fluctuante. Además, se puede asociar a regurgitación no ácida de alimentos o saliva y a pirosis que no responde al uso de inhibidores de la bomba de protones). - Las radiografías baritadas se solicitan cuando se sospecha un divertículo esofágico y también puede ser de ayuda en todas las disfagias, sin ser el examen de elección o de primera línea (lo mismo con la endoscopía, que finalmente se pide en los pacientes con disfagia ilógica también). - La pH-metría de 24 horas es el examen considerado el gold standard para el diagnóstico del RGE, aunque solo se pide si la clínica no es categórica o no hay respuesta al tratamiento con IBP en dos dosis diarias.

Fuente: Gastroenterología, prueba 2 del 21 de abril de 2024, P8

5. Un paciente de 45 años, diagnosticado de reflujo gastroesofágico hace 15 años, en tratamiento con omeprazol 20 mg cada día por vía oral, consulta por aumento de la intensidad de la pirosis, la que, además, se ha vuelto muy frecuente, a pesar de haber subido la dosis a 20 mg cada 12 horas. Su examen físico no aporta mayor información. La conducta más adecuada es:

a. Aumentar la dosis de omeprazol a 20 mg cada 12 horas
b. Realizar tratamiento erradicador de H. pylori
c. Reemplazar el omeprazol por esomeprazol
d. Solicitar pHmetría de 24 horas
e. Solicitar endoscopía digestiva alta

Respuesta correcta: e. Solicitar endoscopía digestiva alta

Explicación: Tiene un RGE con signos de alarma, en específico, el cambio en los síntomas, por lo que se debe realizar una endoscopía, para descartar cáncer de esófago. La pH-metría no es necesaria, porque ya tiene el diagnóstico de RGE. Solo se pide al inicio, cuando existe una clínica poco específica. La pH-metría también se puede hacer cuando los síntomas de RGE no responden al uso de inhibidores de la bomba de protones en dos dosis diarias (como en este caso), pero siempre que eso ocurra al inicio del manejo del RGE, ya que, al no responder, se genera la duda acerca del diagnóstico y la pH-metría se usa para confirmar o descartar la enfermedad, al ser el gold standard para el diagnóstico de RGE. En este caso, en cambio, han pasado muchos años desde el diagnóstico, por lo que la falta de respuesta al tratamiento es un signo de alarma claro.

Fuente: Gastroenterología, prueba 3 del 21 de abril de 2024, P18

6. Un paciente consulta por ardor epigástrico y retroesternal, que ocurre con frecuencia, en especial después de comer. Además, refiere regurgitación frecuente de alimentos. Se solicita una endoscopía digestiva alta que resulta normal. La conducta más adecuada es:

a. Erradicar Helicobacter pylori
b. Solicitar TAC de abdomen y pelvis
c. Diagnosticar dispepsia funcional y realizar educación
d. Solicitar manometría esofágica
e. Iniciar medidas antirreflujo e indicar omeprazol oral

Respuesta correcta: e. Iniciar medidas antirreflujo e indicar omeprazol oral

Explicación: Tiene un RGE clínico, por lo que el diagnóstico ya está hecho y se debe iniciar el tratamiento con medidas generales e inhibidores de la bomba de protones (IBP). No es necesario pedir pH-metría, porque la clínica es categórica (pirosis más regurgitación). Tampoco era necesario pedir la endoscopía (EDA), ya que el diagnóstico era claro. Sí debe pedirse la EDA cuando tiene signos de alarma (para descartar cáncer). Si la endoscopía está normal no descarta el reflujo (aunque la endoscopía con esofagitis distal sí lo confirma). Actualmente, se recomienda tratar a los pacientes con sospecha de RGE y solo si no responden a IBP con dos dosis diarias, complementar el estudio con pH-metría y/o con EDA. Eso sí, en caso de haber signos de alarma, siempre se debe pedir la EDA. La erradicación no ha mostrado mejoría en el RGE, sino que es el tratamiento de la úlcera gastroduodenal. La dispepsia funcional no tiene ni pirosis, ni regurgitación, sino solo epigastralgia urente, con EDA normal.

Fuente: Gastroenterología, prueba 2 del 21 de abril de 2024, P19

Úlcera péptica, Helicobacter pylori y cáncer gástrico (5)

7. Un paciente de 68 años presenta un cuadro de dolor abdominal tipo urente, de algunos meses de evolución, asociado a sensación de plenitud precoz y vómitos frecuentes después de comer. El diagnóstico de sospecha es:

a. Acalasia esofágica
b. Divertículo de Zenker
c. Cáncer de esófago
d. Cáncer gástrico
e. Angina mesentérica

Respuesta correcta: d. Cáncer gástrico

Explicación: Tiene epigastralgia más un síndrome pilórico (vómitos postprandiales y sensación de plenitud), lo que es un cáncer gástrico hasta que se demuestre lo contrario. También puede ser una

cicatriz de una úlcera gástrica, pero la primera causa de síndrome pilórico es el cáncer. Se debe realiza una endoscopía digestiva alta como primer examen, además de exámenes generales (ej. hemograma, etc.).

Fuente: Gastroenterología, prueba 1 del 21 de abril de 2024, P1

8. Un paciente de 69 años consulta por malestar general y baja de peso. Además, refiere saciedad precoz y dolor epigástrico intermitente. La conducta más adecuada para proseguir su estudio es:

a. Solicitar radiografía de abdomen simple
b. Solicitar radiografías baritadas de tórax y abdomen
c. Solicitar endoscopía digestiva alta
d. Solicitar TAC de abdomen con contraste
e. Solicitar ecografía abdominal

Respuesta correcta: c. Solicitar endoscopía digestiva alta

Explicación: Tiene epigastralgia, con signos de alarma: baja de peso, saciedad precoz. Por tanto, se sospecha un cáncer gástrico. Tanto por la sospecha, como por los signos de alarma, se debe realizar endoscopía digestiva alta.

Fuente: Gastroenterología, prueba 2 del 21 de abril de 2024, P5

9. Un paciente consulta por dolor abdominal, por lo que se realiza una endoscopía digestiva alta, que demuestra una úlcera gástrica activa, sin estigmas de sangrado de 1 cm de diámetro. El test de ureasa resulta positivo y la biopsia descarta la presencia de cáncer. La conducta más adecuada es:

a. Resolver quirúrgicamente
b. Indicar omeprazol a permanencia
c. Realizar tratamiento erradicador de Helicobacter pylori
d. Solicitar niveles plasmáticos de gastrina
e. Indicar dieta baja en grasas y prohibir el consumo de alcohol

Respuesta correcta: c. Realizar tratamiento erradicador de Helicobacter pylori

Explicación: El tratamiento de la úlcera gástrica es la erradicación de HP (si es que tiene test de ureasa u otra prueba que confirme la presencia de H. pylori). Además, se deben discontinuar los AINES. La erradicación se realiza con los siguientes esquemas: - Habitual: claritromicina + amoxicilina + IBP. - Alérgicos a amoxicilina: claritromicina + metronidazol o tetraciclina + IBP. - Intolerancia a macrólidos o uso reciente de macrólidos: 4 fármacos (incluyendo bismuto. Ej. Metronidazol + tetraciclina + bismuto + IBP). - Recurrencias: 4 fármacos incluyendo bismuto (Ej. metronidazol + tetraciclina + bismuto + IBP) o 3 fármacos incluyendo levofloxacino (Ej. levofloxacino + metronidazol o tetraciclina + IBP). Solo la úlcera perforada requiere cirugía. El omeprazol u otros IBP se indican por 4-6 semanas y luego se suspende (a menos que tenga otra indicación como RGE o dispepsia funcional). En el RGE, el omeprazol clásicamente, sí se indica a permanencia.

Fuente: Gastroenterología, prueba 3 del 21 de abril de 2024, P5

10. Un paciente presenta un síndrome ulceroso, que ha manejado con omeprazol automedicado. Se solicita una endoscopía digestiva alta, que muestra una úlcera duodenal activa, sin signos de sangrado. El test de ureasa es negativo y niega consumir AINES. Respecto a este paciente, es correcto afirmar que:

a. El resultado del test de ureasa probablemente sea un falso negativo, dado el consumo de omeprazol
b. Se debe indicar omeprazol a permanencia

c. El diagnóstico más probable es cáncer de duodeno
d. La enfermedad celíaca es el diagnóstico más probable
e. La enfermedad de Cröhn es el diagnóstico más probable

Respuesta correcta: a. El resultado del test de ureasa probablemente sea un falso negativo, dado el consumo de omeprazol

Explicación: Es una pregunta difícil. Sin embargo, el 90% de las úlceras duodenales son secundarias a H. pylori y el 10% restante se deben a AINES, con menos de 1% por otras causas. En este caso, no consume AINES, por lo que lo más probable es que sea secundaria a H. pylori. De hecho, las úlceras duodenales siempre se erradican, incluso si el test de ureasa es negativo. Las demás opciones no tienen mucho sentido, en relación a la úlcera.

Fuente: Gastroenterología, prueba 1 del 21 de abril de 2024, P8

11. La etiología más frecuente de la úlcera péptica en Chile es:

a. Infección por Helicobacter pylori
b. Consumo de AINEs
c. Idiopática
d. Consumo de alcohol
e. Gastrinoma

Respuesta correcta: a. Infección por Helicobacter pylori

Explicación: Las úlceras gástricas son 70% por H. pylori y 30% por AINES. Las duodenales son 90% por H. pylori y 10% por AINES. Menos del 1% son por otras causas.

Fuente: Gastroenterología, prueba 2 del 21 de abril de 2024, P13

Hemorragia digestiva (4)

12. Un paciente de 61 años, cirrótico, presenta varios episodios de hematemesis, asociado a ortostatismo. Además de realizar reposición de volumen, se debe:

a. Administrar beta-agonistas adrenérgicos
b. Administrar beta-bloqueadores adrenérgicos
c. Administrar omeprazol endovenoso
d. Instalar un TIPS de manera urgente
e. Realizar una endoscopía de urgencia

Respuesta correcta: e. Realizar una endoscopía de urgencia

Explicación: Se sospecha una hemorragia digestiva alta por várices esofágicos. El tratamiento completo incluye: suero fisiológico endovenoso, ligadura endoscópica de urgencia, terlipresina endovenosa (si no hay, se puede usar octeotride). Además, si tiene ascitis, se deben administrar antibióticos, como profilaxis de PBE y si es alcohólico, se debe administrar tiamina endovenosa. Finalmente, después de haberse manejado el episodio agudo, queda con profilaxis con betabloqueante no selectivos (propanolol oral; "no selectivos" se refiere a que bloquean tanto receptores beta 1, como beta 2); y, en caso de recurrencia, se deben ligar (porque ya han sangrado y la profilaxis secundaria se hace con betabloqueantes más ligadura). En el caso de que haya HDA por VE, de manera recurrente, sí está indicado el TIPS (shunt portosistémico).

Fuente: Gastroenterología, prueba 1 del 21 de abril de 2024, P3

13. Un paciente de 29 años compra un "completo" (pan con salchicha), con mayonesa casera en un carrito de la calle. Tres horas después inicia un cuadro de vómitos alimentarios explosivos, que luego son seguidos de hematemesis en dos oportunidades. El diagnóstico más probable es:

a. Anisakiasis
b. Shiguellosis
c. Várices esofágicas
d. Úlcera péptica
e. Síndrome de Mallory Weiss

Respuesta correcta: e. Síndrome de Mallory Weiss

Explicación: Es un síndrome de Mallory Weiss clásico (hematemesis, luego de vómitos alimentarios). Se produce por una erosión esofágica, secundaria a los vómitos. El cuadro de base, parece una intoxicación por toxina entérica estafilocócica, dado que tiene vómitos a las pocas horas de haber comido el completo. Si hubiese comido pescado crudo, sería anisakiasis.

Fuente: Gastroenterología, prueba 2 del 21 de abril de 2024, P6

14. Un paciente cirrótico por consumo de alcohol, consulta por un episodio de hematemesis, asociado a malestar general, que sucedió hace 15 minutos. Al examen físico se aprecia pálido. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

a. Várices esofágicas sangrantes
b. Síndrome de Mallory Weiss
c. Úlcera gastroduodenal complicada
d. Hepatocarcinoma
e. Cáncer gástrico

Respuesta correcta: a. Várices esofágicas sangrantes

Explicación: Cirrótico más hematemesis es lo clásico de la hemorragia variceal. El síndrome de Mallory Weiss también tiene hematemesis, pero necesariamente viene precedida por vómitos alimentarios, sin sangre.

Fuente: Gastroenterología, prueba 3 del 21 de abril de 2024, P8

15. Un paciente de 69 años presenta un episodio de hematoquecia escasa, autolimitada. Su examen físico es normal y no ha presentado otros síntomas. La conducta más adecuada es:

a. Observar evolución e indicar control en caso de aparición de signos de alarma
b. Solicitar TAC de abdomen y pelvis
c. Solicitar colonoscopía
d. Solicitar coprocultivo y examen parasitológico de deposiciones
e. Solicitar test de sangre oculta ultrasensible en deposiciones

Respuesta correcta: c. Solicitar colonoscopía

Explicación: Si bien puede tratarse de simples hemorroides, la hematoquecia (también se suele escribir “hematoquezia”, aunque la RAE solo acepta usar la C y no la Z) siempre se estudia con colonoscopía. Más aún si es un adulto mayor, ya que es obligatorio descartar el cáncer. El test de sangre oculta en deposiciones es inferior a la colonoscopía (aunque en la práctica se pida mucho), ya que incluso para el screening en un paciente asintomático, se recomienda la colonoscopía, desde los 50 años y en los

pacientes sintomáticos, definitivamente no se recomienda el uso del test de sangre oculta (además, es algo ridículo buscar "sangre oculta" cuando ya hubo sangrado evidente, como en este caso).

Fuente: Gastroenterología, prueba 3 del 21 de abril de 2024, P16

Hepatitis agudas y crónicas (7)

16. Un paciente de 18 años consulta por ictericia y malestar general. Refiere que desde hace una semana inició con un cuadro de odinofagia y fiebre, por lo que ha tomado paracetamol 1 gramo cada 8 horas. Sin embargo, hace un día comenzó a ponerse amarillo, por lo que decidió consultar. Al examen físico se palpan adenopatías cervicales y axilares, se observa ictericia de escleras y piel y se palpa hepatomegalia, levemente sensible y bazo 2 cm bajo el reborde costal. Se solicita perfil hepático que muestra GOT: 730 UI/L, GPT: 626 UI/L, GGT: 262 UI/L, FA: 340 UI/L, bilirrubina total: 4,1 mg/dl, con bilirrubina directa: 2,9 mg/dl, albúmina: 4,4 g/dl y protrombinemia: 90%. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

a. Hepatitis B
b. Hepatitis alcohólica
c. Hepatitis A
d. Hepatitis por virus de Ebstein Baar
e. Hepatitis por fármacos

Respuesta correcta: d. Hepatitis por virus de Ebstein Baar

Explicación: Tiene una hepatitis aguda, probablemente viral. El antecedente de odinofagia, adenopatías y esplenomegalia (también se puede ver en hepatitis crónicas con hipertensión portal) hace más probable a una mononucleosis que a una hepatitis A o B. El paracetamol en esa dosis no produce hepatitis. El perfil hepático muestra un patrón hepatítico, con elevación marcada de las transaminasas, hiperbilirrubinemia directa y ausencia de disfunción hepática (protrombinemia y albúmina normales).

Fuente: Gastroenterología, prueba 4 del 21 de abril de 2024, P6

17. Un paciente de 35 años, alcohólico, presenta un cuadro de malestar general, ictericia, fiebre y vómitos. Se solicitan exámenes que muestran: lipasa: 100 UI/L, GGT: 345 UI/L, GOT: 350 UI/L, GPT: 106 UI/L, bilirrubina: 3,8 mg/dl, fosfatasas alcalinas: 108 UI/L. El diagnóstico más probable es:

a. Pancreatitis aguda
b. Pancreatitis crónica
c. Colédocolitiasis
d. Hepatitis alcohólica
e. Hepatitis viral

Respuesta correcta: d. Hepatitis alcohólica

Explicación: Dado que la relación GOT/GPT es mayor a 2 (350/106 = 3,3), es una hepatitis alcohólica. Siempre hay que fijarse en dicha relación, antes de contestar las preguntas de hepatitis. La GGT además, está elevada porque es un marcador del consumo de alcohol.

Fuente: Gastroenterología, prueba 1 del 21 de abril de 2024, P7

18. Un paciente cirrótico, de reciente diagnóstico, se realiza pruebas de detección de virus hepatotropos, que muestran IgG-VHA(+), IgM-VHA(-), Ag-VHBs(+), IgG-VHBs(-), IgM-VHBs(-), IgG-VHBc(+), IgM-VHBc(-), IgG-VHC(-), IgM-VHC(-). El diagnóstico más probable es:

a. Hepatitis A
b. Hepatitis B aguda

c. Hepatitis B crónica
d. Hepatitis A y B
e. Hepatitis de causa no viral

Respuesta correcta: c. Hepatitis B crónica

Explicación: Tiene la IgM-VHA negativa, por lo que no tiene hepatitis A. Dado que la IgG-VHA está positiva, quiere decir que está vacunado o que tuvo hepatitis A antes y se mejoró. Tiene el antígeno de superficie (Ag-VHB) positivo, por lo que tiene hepatitis B (recordar que el antígeno es un "pedazo de virus"). Como la IgM anticore (IgM-VHBc) está negativa, no puede ser aguda y por obligación debe ser hepatitis B crónica. Tiene la serología contra la hepatitis C negativa, por lo que no tiene hepatitis C. Si hubiese tenido cualquier anticuerpo contra el virus C positivo, lo más probable es que habría sido hepatitis C (como la hepatitis C cronifica en el 90% de los casos, tanto IgG como IgM positiva, se manejan similarmente, confirmando con PCR-VHC y luego dando antivirales).

Fuente: Gastroenterología, prueba 2 del 21 de abril de 2024, P7

19. Un paciente, con antecedente de promiscuidad sexual, presenta un cuadro de malestar general, gran decaimiento y posteriormente, aparición de ictericia de escleras, mucosas y piel, asociada a coluria y acolia. Se solicitan exámenes, que muestran positividad del antígeno de superficie para VHB y de los anticuerpos IgM anti-core. ¿Qué examen es más adecuado para determinar la gravedad de este paciente?

a. Biopsia hepática
b. Niveles plasmáticos de Antígeno de superficie
c. Tiempo de protrombina
d. Niveles plasmáticos de GOT
e. Niveles plasmáticos de bilirrubina

Respuesta correcta: c. Tiempo de protrombina

Explicación: Tiene una hepatitis B aguda, confirmada: Ag-VHBs(+) más IgM- VHBs(+). Al igual que todas las hepatitis agudas, la gravedad se determina con la protrombinemia o tiempo de protrombina, ya que marca el riesgo de progresión a una hepatitis fulminante (se agrega encefalopatía y luego falla multiorgánica).

Fuente: Gastroenterología, prueba 1 del 21 de abril de 2024, P9

20. Un paciente cirrótico por consumo de alcohol, es traído a la urgencia por sus familiares por un cuadro de dolor abdominal y vómitos, al que luego se agregó desorientación. En su examen físico está ictérico y presenta signos clínicos de ascitis. Su hálito es alcohólico y presenta desorientación y sopor superficial. Se solicitan exámenes, entre los que destaca un hemograma con leucocitosis y pruebas hepáticas que muestran GOT: 302 UI/L, GPT: 144 UI/L, GGT: 355 UI/L, FA: 108 UI/L, bilirrubina: 5,2 UI/L, protrombinemia: 78% y albúmina: 3,4 g/dl. El diagnóstico más probable es:

a. Colangitis aguda
b. Peritonitis bacteriana espontánea
c. Hepatocarcinoma
d. Pancreatitis aguda
e. Hepatitis alcohólica

Respuesta correcta: e. Hepatitis alcohólica

Explicación: Por la clínica puede ser cualquier causa de hepatitis, pero lo importante es que están elevadas las transaminasas, con una relación GOT/GPT mayor a 2, lo que es diagnóstico de hepatitis

alcohólica. Por eso, siempre se debe mirar la reación GOT/GPT antes de contestar la pregunta de hepatitis, ya que, incluso en relaciones mayores a 1,5 ya se debe sospechar fuertemente la etiología alcohólica en las hepatitis agudas de quienes consumen alcohol. En este caso, además hay ciertos indicadores de gravedad, como la protrombinemia menor a 80%.

Fuente: Gastroenterología, prueba 2 del 21 de abril de 2024, P11

21. Un paciente, con elevación de las transaminasas, presenta las siguientes serologías para virus de la hepatitis: IgG-VHA(+), IgM- VHA(-), Ag-VHBs(-), IgG-VHBs(+), IgM-VHBc(-), IgG-VHBc(+), IgG- VHC(-), IgM-VHC(-). El diagnóstico más probable es:

a. Hepatitis A
b. Hepatitis B aguda
c. Hepatitis B crónica
d. Hepatitis C
e. Hepatitis de causa no viral

Respuesta correcta: e. Hepatitis de causa no viral

Explicación: Tiene la IgM-VHA negativa, por lo que no tiene hepatitis A. Dado que la IgG-VHA está positiva, quiere decir que está vacunado o que tuvo hepatitis A antes y se mejoró. Tiene el antígeno de superficie (Ag-VHB) negativo, por lo que no tiene hepatitis B. Como la IgM anticore (IgM-VHBc) está negativa, tampoco puede ser hepatitis B aguda en periodo de ventana (en el que se detecta la IgM anticore, pero no el antígeno aún). Por tener positivas las IgG, tanto anti superficie, como anticore, se sabe que tuvo hepatitis B antes, pero que se mejoró. Tiene la serología contra la hepatitis C negativa, por lo que no tiene hepatitis C. Si hubiese tenido cualquier anticuerpo contra el virus C positivo, lo más probable es que habría sido hepatitis C (como la hepatitis C suele cronificar, no importa si tiene IgG o IgM positiva para VHC: el manejo es el mismo, confirmando el diagnóstico con una PCR y luego indicando antivirales).

Fuente: Gastroenterología, prueba 3 del 21 de abril de 2024, P13

22. Un paciente consulta por ictericia, constándose elevación marcada de las transaminasas. Se solicitan pruebas de serología viral que demuestran VHA-Ac IgM(-), VHA-Ac IgG (+), VHBs-Ag(+), VHBs-Ac(-), VHBcore-Ac IgM(+), VHBcore-Ac IgG(-), VHC-Ac totales(+). El diagnóstico más probable es:

a. Hepatitis B
b. Hepatitis C
c. Hepatitis A y B
d. Hepatitis B y C
e. Hepatitis A, B y C

Respuesta correcta: d. Hepatitis B y C

Explicación: Tiene IgM-VHA negativo, por lo que no tiene una hepatitis A. La IgG-VHA positiva indica que ya tuvo o que está vacunado. Tiene el antígeno de superficie de VHB positivo, lo que indica que tiene una hepatitis B. Además, la IgM anticore VHB está positiva, por lo que es una hepatitis B aguda. Finalmente tiene los anticuerpos totales contra VHC positivos, por lo que también tiene hepatitis C.

Fuente: Gastroenterología, prueba 1 del 21 de abril de 2024, P15

Hepatopatías crónicas, hígado graso y autoinmunes (6)

23. Una paciente de 50 años consulta por astenia marcada, que ha ido en aumento. No presenta otros síntomas y su examen físico no tiene alteraciones. Se solicitan exámenes generales, entre los que destaca

un hemograma normal, creatinina: 0,8 mg/dl, GOT: 60 UI/L, GPT: 64 UI/L, Bilirrubina: 2,8 mg/dl, Bilirrubina directa: 2,5 mg/dl, GGT: 180 UI/L, FA: 466 UI/L. El diagnóstico de sospecha es:

a. NASH
b. Hepatitis autoinmune
c. Cáncer de vesicular biliar
d. Colangitis esclerosante primaria
e. Cirrosis biliar primaria

Respuesta correcta: e. Cirrosis biliar primaria

Explicación: Es una colangitis biliar primaria o cirrosis biliar primaria (CBP) clásica: mujer de 40-50 años, habitualmente multípara, con astenia marcada y colestasia en las pruebas hepáticas, con especial elevación de las FA. Su marcador son los anticuerpos antimitocondriales (AMA) y su diagnóstico se basa en los exámenes de laboratorio más los anticuerpos y, si bien la biopsia no suele indispensable para el diagnóstico, sí sirve mucho para ver el grado de daño hepático que se ha generado y también muestra la clásica destrucción de la vía biliar intrahepática. Las imágenes suelen estar normales o mostrar alteraciones inespecíficas, porque no hay afectación de la vía biliar extrahepática. El tratamiento es con ácido ursodeoxicólico. La hepatitis autoinmune tendría elevación de las transaminasas. El cáncer de vesícula biliar tendría colestasia, sin dolor, pero de edad algo mayor y con predominio de la ictericia, por sobre la astenia. La colangitis esclerosante primaria es más frecuente en personas de menor edad, asociada a enfermedades inflamatorias intestinales, en especial, colitis ulcerosa. Más allá de eso, la clínica puede ser igual a la CBP.

Fuente: Gastroenterología, prueba 2 del 21 de abril de 2024, P1

24. Una mujer de 41 años, sin antecedentes mórbidos, consulta por astenia y náuseas. Su examen físico es normal. Se solicitan exámenes generales, entre los que destaca un perfil hepático, con GOT: 30 UI/L, GPT: 26 UI/L, GGT: 62 UI/L, FA: 540 UI/L, bilirrubina total: 2,0 mg/dl, con bilirrubina directa: 0,9 mg/dl, albúmina: 4 g/dl y protrombinemia: 100%. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

a. Cáncer de vesícula
b. Cirrosis biliar primaria
c. Hígado graso
d. Cáncer de páncreas
e. Síndrome de Gilbert

Respuesta correcta: b. Cirrosis biliar primaria

Explicación: Es una colangitis biliar primaria o cirrosis biliar primaria (CBP) clásica, que afecta a mujeres de edad media, habitualmente multíparas y que tiene una clínica muy inespecífica de astenia y, a veces, náuseas y prurito. Se caracteriza por elevación de las fosfatasas alcalinas y, además, puede o no elevar los otros marcadores de colestasia, como la GGT o la bilirrubina. En este caso, la hiperbilirrubinemia es de predominio directo, ya que la fracción directa o conjugada es más del 30% del total. El marcador de la CBP son los anticuerpos antimitocondriales (AMA), que tienen 95% de sensibilidad y 98% de especificidad, por lo que se asocian fuertemente con esta patología. La biopsia muestra destrucción de los canalículos intrahepáticos y confirma el diagnóstico, pero hay muchos casos en los que no es necesaria la biopsia. No hay alteración de la vía biliar extrahepática en las imágenes. El tratamiento suele ser con ácido ursodeoxicólico y, cuando evoluciona a cirrosis más grave, se maneja con trasplante hepático. Además, se protege el hígado, evitando hepatotóxicos (ej. alcohol) y vacunando contra los virus de la hepatitis.

Fuente: Gastroenterología, prueba 4 del 21 de abril de 2024, P5

25. Un paciente obeso, diabético de 50 años se realiza exámenes generales a modo de chequeo, entre los que destaca elevación de las transaminasas por 3 veces el valor normal. Las pruebas colestásicas están normales, dice no consumir alcohol, excepto muy pocas ocasiones al año, niega conductas sexuales de riesgo y nunca ha recibido transfusiones. El diagnóstico más probable es:

a. Hepatiits A
b. Hepatitis B
c. Hepatitis autoinmune
d. Esteatohepatitis no alcohólica
e. Síndrome de Gilbert

Respuesta correcta: d. Esteatohepatitis no alcohólica

Explicación: Tiene hepatitis, porque las transaminasas están elevadas. Además, por el antecedente de diabetes, lo más probable es que tenga una esteatohepatitis no alcohólica, ya que es la primera causa de hepatitis crónica y se produce por resistencia a la insulina. La confirmación diagnóstica incluye 1. solicitar una ecografía (u otra imagen) que demuestre la esteatosis hepática y 2. descartar otras causas de hepatitis con múltiples exámenes (marcadores virales y marcadores de hepatitis autoinmune). El tratamiento es con dieta, ejercicio, baja de peso y manejo de la resistencia a la insulina, que se considera la causa. También se debe evitar el alcohol y otros hepatotóxicos.

Fuente: Gastroenterología, prueba 2 del 21 de abril de 2024, P12

26. La positividad de los anticuerpos anti-músculo liso es característica de:

a. Hepatitis autoinmune
b. Colangitis esclerosante primaria
c. Cirrosis biliar primaria
d. Atresia biliar
e. Amiloidosis

Respuesta correcta: a. Hepatitis autoinmune

Explicación: La hepatitis autoinmune tiene como marcadores a los ANA (antinucleares), ASMA (antimúsculo liso) que reflejan la presencia de los AAA (antiactina) y antiLKM1 (antimicrosomales). Recordar la fase “Ana tiene muy mala suerte, porque tiene ASMA, hepatitis autoinmune y hasta una cosa rara que se llama antiLKM1”. La colangitis esclerosante primaria suele tener ANCA (anticitoplasma de neutrófilo). La cirrosis biliar primaria tiene AMA (antimitocondriales).

Fuente: Gastroenterología, prueba 1 del 21 de abril de 2024, P13

27. El hígado graso se diagnostica preferentemente mediante:

a. La clínica
b. El perfil lipídico
c. La ecografía abdominal
d. Las pruebas hepáticas
e. La biopsia hepática

Respuesta correcta: c. La ecografía abdominal

Explicación: El hígado graso no alcohólico (también llamado NAFL, por sus siglas en inglés: NonAlcoholic Fatty Liver) se diagnostica con la biopsia hepática o con una imagen (ecografía, TAC o RMN). De todos los exámenes, de elección es la ecografía abdominal, la que muestra un patrón hiperecogénico del

parénquima hepático, que puede ser más hiperecogénico en la superficie y luego va disminuyendo la ecogenicidad hacia profundo. Si además se agrega elevación de las transaminasas, el diagnóstico cambia a NASH (NonAlcoholic SteatoHepatitis). El diagnóstico se confirma cuando 1. se demuestra esteatosis en imágenes o biopsia, 2. no tiene daño hepático crónico y 3. no hay otras causas de esteatosis hepática (ej. no consume alcohol en cantidades que puedan generar hepatopatía); en resumen: es un diagnóstico de descarte. Si consume alcohol en alta cantidad y tiene hígado graso, pues se llama hepatopatía alcohólica con esteatosis.

Fuente: Gastroenterología, prueba 1 del 21 de abril de 2024, P14

28. ¿Cuál de los siguientes anticuerpos es un marcador de hepatitis autoinmune?

a. Anti-mitocondriales
b. Anti-músculo liso
c. Anti-citoplasma de neutrófilo
d. Anti-saccharomyces
e. Anti-endomisio

Respuesta correcta: b. Anti-músculo liso

Explicación: - Antimitocondriales (AMA) – Cirrosis biliar primaria - Anti-músculo liso (ASMA) – Hepatitis autoinmune (también anti-LKM1 y ANA). - Anti-citoplasma de neutrófilo (ANCA) – Colangitis esclerosante y colitis ulcerosa (más vasculitis) - Anti-saccharomyces (ASCA) – Enfermedad de Cröhn - Anti-endomisio – Enfermedad celíaca

Fuente: Gastroenterología, prueba 3 del 21 de abril de 2024, P15

Cirrosis hepática y sus complicaciones (6)

29. Un paciente de 56 años, portador de una cirrosis por consumo crónico de alcohol, consulta por aumento del perímetro abdominal. Actualmente ya no consume alcohol y presenta ascitis moderada en el examen físico, la que se confirma con una ecografía. Se realiza paracentesis diagnóstica, que muestra salida de líquido ascítico transparente con 10 células por mm3 y albúmina de 2,2 g/dl. La conducta más adecuada es:

a. Realizar paracentesis evacuadora, con reposición de albúmina
b. Iniciar antibióticos por vía endovenosa
c. Iniciar antibióticos orales, de manera profiláctica
d. Iniciar espironolactona y furosemida
e. Instalar un TIPS

Respuesta correcta: d. Iniciar espironolactona y furosemida

Explicación: Tiene una ascitis simple, la que se trata con diuréticos (se recomienda iniciar simultáneamente con espironolactona 100 mg y furosemida 40 mg al día, pudiendo subir la dosis hasta el cuádruple) y restricción salina. Si no hay hiponatremia no se recomienda actualmente restringir el agua de manera estricta, ya que no ha mostrado mayores beneficios y la restricción de agua produce malestar por sed. El tratamiento de la ascitis a tensión es la evacuación, con reposición de albúmina (8 gramos por litro sacado). Eso sí, primero se debe descartar peritonitis bacteriana espontánea (PBE). La PBE se trata con antibióticos endovenosos (cefotaximo) y luego queda con profilaxis antibiótica oral (ciprofloxacino o cotrimoxazol). En este caso no hay PBE, ya que requiere de más de 250 polimorfonucleares por mm3 en líquido ascítico. La ascitis refractaria se trata con paracentesis periódicas o con TIPS. Algo importante a

recordar es que la presencia de ascitis, por sí misma, es un marcador de mal pronóstico en el paciente cirrótico, por lo que el manejo definitivo suele ser el trasplante hepático.

Fuente: Gastroenterología, prueba 1 del 21 de abril de 2024, P2

30. ¿Cuál de los siguientes medicamentos es más útil para el tratamiento de la encefalopatía hepática?

a. Donepezilo
b. Ácido valproico
c. Fluoxetina
d. Risperidona
e. Lactulosa

Respuesta correcta: e. Lactulosa

Explicación: Lo más importante es buscar una causa descompensante y tratarla, pero como fármaco adicional, sirve la lactulosa (laxante osmótico) o bien la rifaximina o neomicina (ambos antibióticos no reabsorbibles, que actúan también como agentes osmóticos). En la actualidad se prefiere la lactulosa por sobre los antibióticos, debido a que su eficacia es igual y su costo es mucho menor. Además, se prefiere la rifaximina sobre la neomicina si se decide dejar un antibiótico, ya que podría tener más efectos adversos. Resumen: lactulosa XD.

Fuente: Gastroenterología, prueba 3 del 21 de abril de 2024, P2

31. Un paciente de 45 años, portador del virus hepatitis C, con daño hepático crónico en score de Child A, se realiza una ecografía de control, que muestra ascitis moderada. Se realiza endoscopía digestiva alta, que muestra várices esofágicas pequeñas (menores a 5 mm), sin signos rojos ni otras alteraciones. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

a. Indicar dieta con restricción hidrosalina más diuréticos por vía oral
b. Iniciar propanolol oral
c. Realizar paracentesis evacuadora y ligadura endoscópica de las várices
d. Administrar antibióticos, albúmina y propanolol por vía endovenosa
e. Administrar albúmina endovenosa e iniciar propanolol

Respuesta correcta: a. Indicar dieta con restricción hidrosalina más diuréticos por vía oral

Explicación: Tiene dos complicaciones de la hipertensión portal: ascitis y várices esofágicas. La ascitis no complicada se maneja con restricción de sal (la restricción de agua solo se indica en pacientes con hiponatremia importante) más diuréticos (actualmente se recomienda partir directamente con 2 diuréticos, en lugar de uno: furosemida 40 mg más espironolactona 100 mg y se va subiendo la dosis, en caso necesario, llegando al cuádruple 160mg y 400mg, respectivamente); si está a tensión se hace paracentesis evacuadora más reposición de albúmina; si se infecta, como una peritonitis bacteriana espontánea, se maneja con antibióticos endovenosos y albúmina, quedando con antibióticos orales a permanencia, mientras dure la ascitis. Las várices esofágicas que no han sangrado se manejan con propanolol, nadolol o carvedilol (carvedilol solo en pacientes con cirrosis compensada). Las que ya han sangrado alguna vez, además, se deben ligar. Las que están sangrando, se manejan como una hemorragia digestiva alta, con ligadura endoscópica urgente y terlipresina (análogo de la vasopresina) u octeotride (análogo de la somatostatina), por vía endovenosa (el octeotride es menos eficaz que la vasopresina en estos casos). La única excepción son las várices pequeñas (menores a 5 mm), sin signos rojos (zonas de la mucosa que se ve más roja, debido al adelgazamiento de la pared de la várice), que se pueden observar y controlar con endoscopía anualmente. Ese es el caso de esta pregunta.

Fuente: Gastroenterología, prueba 4 del 21 de abril de 2024, P4

32. Un paciente de 60 años, cirrótico por consumo de alcohol, se realiza una endoscopía digestiva alta que muestra várices esofágicas medianas, sin signos de sangrado ni puntos rojos. El paciente no ha tenido síntomas y no consume alcohol desde hace 2 años. La conducta más adecuada es:

a. Iniciar lactulosa oral
b. Iniciar propanolol oral
c. Realizar instalación de un TIPS
d. Proceder a la ligadura de las várices esofágicas por vía endoscópica
e. Observar evolución

Respuesta correcta: b. Iniciar propanolol oral

Explicación: Tiene várices esofágicas, que nunca han sangrado, por lo que requieren profilaxis primaria, que se realiza con betabloqueantes no selectivos: propanolol o carvedilol. Si ya hubiesen sangrado, se indicaría profilaxis secundaria, con ligadura más propanolol. Si tuviese contraindicación del propanolol (ej. asma o EPOC), se indicaría la ligadura sola. La lactulosa es el tratamiento de la encefalopatía hepática. Solo las várices pequeñas (menores a 5 mm de diámetro) y sin ya que no aún no existe evidencia de buena calidad que muestre beneficios del uso de betabloqueo en pacientes sin várices o con várices pequeñas y bajo riesgo. Si tiene puntos rojos (y, según algunos, también si tiene clasificación Child-Pugh C) sí se puede dar betabloqueantes a las várices pequeñas. Recordar que betabloqueo no selectivos (bloquean receptores adrenérgicos beta1 y beta2) son propanolol, nadolol, timolol y carvedilol (que también es alfa1 bloqueante). En cambio los cardioselectivos solo bloquean los receptores beta1 (no se usan en cirrosis) y corresponden a atenolol, metoprolol, bisoprolol y esmolol.

Fuente: Gastroenterología, prueba 2 del 21 de abril de 2024, P17

33. Un paciente de 50 años, con antecedente de daño hepático crónico, consulta por dolor abdominal y sensación febril. Al examen físico se aprecia ictérico, con abdomen doloroso a la palpación, con ascitis franca, con presencia de signo de la ola y matidez desplazable. Además, presenta asterixis. La conducta inicial más adecuada es:

a. Solicitar amonemia plasmática
b. Solicitar colangioresonancia
c. Realizar paracentesis diagnóstica
d. Realizar paracentesis evacuadora
e. Resolver quirúrgicamente de inmediato

Respuesta correcta: c. Realizar paracentesis diagnóstica

Explicación: Todo paciente cirrótico, con ascitis, que se descompense, de la manera que sea, lo primero es descartar una PBE (peritonitis bacteriana espontánea), por lo que se debe hacer una paracentesis diagnóstica. En este caso tiene una encefalopatía, por lo que eventualmente podría servir la amonemia, ya que el amonio es un marcador de encefalopatía hepática. Sin embargo, lo más importante siempre es buscar los descompensantes y el primero a descartar siempre es la PBE.

Fuente: Gastroenterología, prueba 3 del 21 de abril de 2024, P17

34. ¿Cuál de los siguientes tratamientos le parece más adecuado para un paciente cursando una peritonitis bacteriana espontánea?

a. Paracentesis evacuadora más antibióticos endovenosos
b. Cefotaximo endovenoso más albúmina endovenosa
c. Ceftriaxona intraperitoneal

d. Diuréticos orales
e. Ciprofloxacino oral

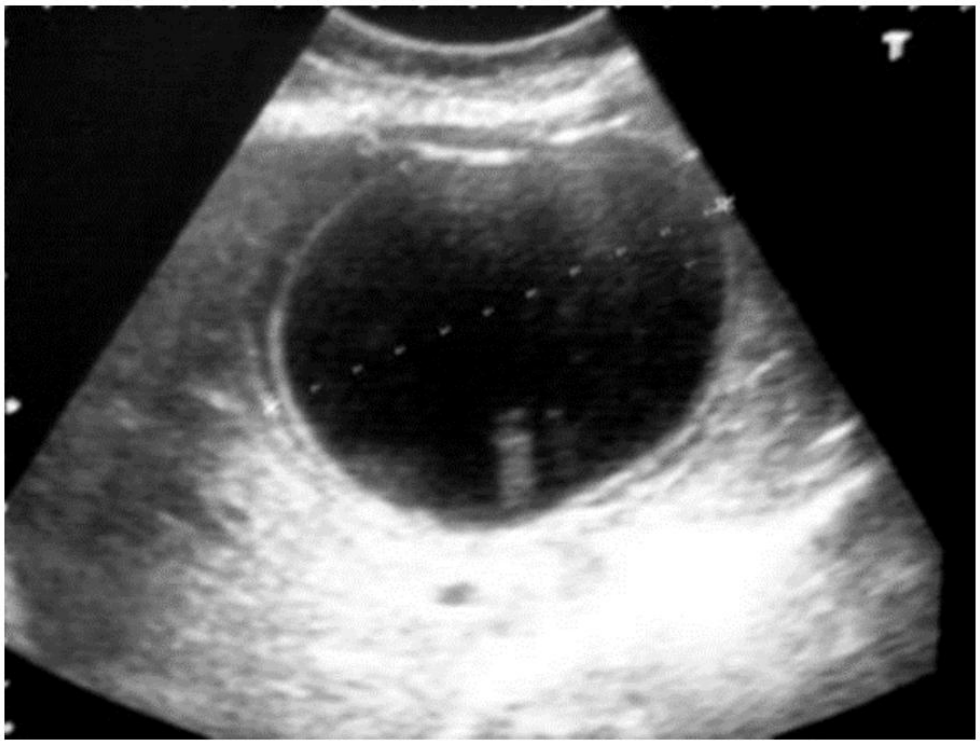
Respuesta correcta: b. Cefotaximo endovenoso más albúmina endovenosa

Explicación: El tratamiento de la PBE es con cefotaximo endovenoso 2 g cada 8 horas por 7 días (en alérgicos, se puede usar ciprofloxacino endovenoso y en los casos muy graves, se puede usar imipenem u otro carbapenémico). Además, se administra albúmina endovenosa, como profilaxis de síndrome hepatorrenal: 1,5 g/Kg de peso corporal en las primeras 6 horas del diagnóstico y, al tercer día, se da 1 g/Kg de peso. Después queda con profilaxis con cotrimoxazol, ciprofloxacino u otra quinolona, durante todo el tiempo que permanezca con ascitis (hasta el trasplante o la muerte). La paracentesis evacuadora en la PBE está del todo contraindicada, ya que puede desencadenar un síndrome hepatorrenal. Si bien las PBE suelen responder bien al tratamiento, su pronóstico a largo plazo es malo, ya que son un marcador de daño hepático avanzado (recordar que la mediana de sobrevida de los pacientes con ascitis es de apenas 2 a 3 años y que a 5 años la sobrevida es de apenas un tercio de los pacientes). Por eso, desde que hay ascitis habitualmente ya se debe empezar a considerar la posibilidad de un trasplante hepático.

Fuente: Gastroenterología, prueba 2 del 21 de abril de 2024, P20

Lesiones focales hepáticas y hepatocarcinoma (4)

35. Un paciente de 65 años, campesino, se realiza una ecografía abdominal, como parte del estudio de dolor abdominal, que visualiza la siguiente imagen (fuente: "diagnóstico".blogspot.com/2006/06/): ¿Cuál es el diagnóstico más adecuado?



a. Quiste simple
b. Adenoma
c. Hemangioma
d. Quiste hidatídico

e. Colelitiasis

Respuesta correcta: d. Quiste hidatídico

Explicación: Tiene el aspecto clásico del quiste hidatídico, con la visualización de la pared, lo que lo diferencia del quiste hepático simple.

Fuente: Gastroenterología, prueba 4 del 21 de abril de 2024, P3

36. Un paciente de 60 años se realiza una ecografía abdominal, como parte del estudio de un cuadro crónico de dolor abdominal, el que muestra 3 lesiones redondeadas, hipoecogénicas, de 8, 12 y 15 mm de diámetro respectivamente, ubicadas en el lóbulo hepático derecho. El diagnóstico más probable es:

a. Quistes simples
b. Quistes hidatídicos
c. Hemangiomas
d. Hepatocarcinomas
e. Metástasis

Respuesta correcta: e. Metástasis

Explicación: Son metástasis clásicas: lesiones múltiples hipoecogénicas. Los quistes simples son anecogénicos, sin pared. Los quistes hidatídicos son anecogénicos, con pared y/o tabiques. Los hemangiomas son hiperecogénicos. Los hepatocarcinomas son hipoecogénicos, de aspecto heterogéneo y únicos (hay casos en que hay dos, en especial en cirróticos).

Fuente: Gastroenterología, prueba 2 del 21 de abril de 2024, P10

37. El hepatocarcinoma se asocia a cirrosis hepática de distintas etiologías. ¿Qué marcador serológico se suele elevar en los pacientes con este tipo de tumor?

a. Ca 19.9
b. Ca 125
c. Antígeno carcinoembrionario
d. Alfafetoproteína
e. Ferritina decarboxilada

Respuesta correcta: d. Alfafetoproteína

Explicación: - Ca 19.9: cáncer de páncreas (también se puede elevar en cirrosis y coledocolitiasis). - Ca 125: cáncer de ovario (y también endometriosis y otros procesos peritoneales). - Antígeno carcinoembrionario: cáncer de colon (también se eleva en otros cánceres, como vesícula y páncreas). - Alfafetoproteína: hepatocarcinoma, cáncer de testículo no seminoma y defectos del tubo neural (espina bífida y anencefalia). - Ferritina decarboxilada: marcado de consumo de alcohol (junto con VCM alto y GGT elevada).

Fuente: Gastroenterología, prueba 1 del 21 de abril de 2024, P18

38. Un paciente cirrótico por VHC, consulta por malestar general y desorientación. Se realizan varios exámenes entre los que destaca una ecografía abdominal con un tumor hepático de 8 cm de diámetro, de ecogenicidad heterogénea y aspecto sólido. El diagnóstico más probable es:

a. Metástasis hepática
b. Hemangioma
c. Carcinoma hepatocelular
d. Colangiocarcinoma

e. Quiste hidatídico

Respuesta correcta: c. Carcinoma hepatocelular

Explicación: Es un hepatocarcinoma clásico: Lesión grande, única y muy irregular. En especial si es un cirrótico y más aún si tiene hepatitis C. - Los hemangiomas son hiperecogénicos y, generalmente, homogéneos. - Las metástasis suelen ser lesiones múltiples hipoecogénicas. - El colangiocarcinoma puede verse igual al hepatocarcinoma, pero es mucho más infrecuente y se suele presentar con más ictericia. - Los quistes simples son anecogénicos, sin pared. - Los quistes hidatídicos son anecogénicos, con pared y/o tabiques. - Los adenomas son una lesión única hipoecogénica, pero regular. También es más frecuente en los cirróticos y pacientes con hepatiits C ytienen riesgo de volverse malignos.

Fuente: Gastroenterología, prueba 3 del 21 de abril de 2024, P20

Vía biliar y vesícula (6)

39. Un paciente de 56 años consulta por dolor abdominal intenso de 8 horas de evolución, que se ha asociado a vómitos alimentarios en varias oportunidades. El dolor es de localización epigástrico, sin irradiación. Al examen físico se aprecia ictérico en piel y mucosas y su abdomen es doloroso a la palpación del epigastrio e hipocondrio derecho. Se solicita una ecografía abdominal, que muestra dilatación de la vía biliar intrahepática y extrahepática. La conducta más adecuada es:

a. Solicitar colangioresonancia
b. Hospitalizar, iniciar antibióticos y analgésicos por vía endovenosa
c. Realizar CPRE
d. Solicitar radiografía de tórax en posición de pie
e. Resolver quirúrgicamente de inmediato

Respuesta correcta: a. Solicitar colangioresonancia

Explicación: La sospecha clínica es una coledocolitiasis (dolor más ictericia y vómitos, sin fiebre). Su enfrentamiento diagnóstico es algo que tiene algún grado de debate. En este caso, la ecografía es sugerente, pero aún no ha visualizado los cálculos, por lo que se debe hacer la colangioRMN, antes de proceder a la CPRE (colangiografía retrógrada endoscópica, que aunque es diagnóstica, también es el procedimiento terapéutico más importante). 1. Si la ecografía hubiese visto los cálculos en el colédoco, o 2. si hubiese clínica de colangitis (más fiebre), se debería hacer la CPRE directamente. También se hace la CPRE cuando 3. la colangioRMN muestra los cálculos en el colédoco. Algunas guías internacionales incluyen a 4. los pacientes sin colecistectomía con dolor e ictericia más colédoco dilatado más bilirrubina mayor a 4 mg/dl como candidatos a las CPRE de manera directa.

Fuente: Gastroenterología, prueba 2 del 21 de abril de 2024, P2

40. Un paciente de 60 años, con antecedente de cirrosis hepática alcohólica, consulta por dolor abdominal de varios meses de evolución, que aparece después de comer y que se ha vuelto más intenso. Además, presenta diarrea con frecuencia, con gotas de grasa. Su examen físico solo muestra dolor a la palpación epigástrica, sin signos peritoneales. ¿Qué examen es el más adecuado para iniciar el diagnóstico en este paciente?

a. Colangiopancreatografía por resonancia magnética nuclear
b. Endoscopía digestiva alta
c. Angiografía mesentérica
d. Anticuerpos anti-transglutaminasa
e. Ecografía abdominal

Respuesta correcta: a. Colangiopancreatografía por resonancia magnética nuclear

Explicación: La sospecha es una pancreatitis crónica, por lo que se debe estudiar con la TAC o la colangiopancreatografía por RMN. El antecedente de alcoholismo y el dolor postprandial son los elementos clave para sospechar este diagnóstico.

Fuente: Gastroenterología, prueba 4 del 21 de abril de 2024, P8

41. Una paciente de 80 años presenta ictericia y coluria de una semana de evolución, sin otros síntomas. El diagnóstico más probable es:

a. Cáncer
b. Coledocolitiasis
c. Hepatitis
d. Síndrome de Gilbert
e. Hemólisis

Respuesta correcta: a. Cáncer

Explicación: Tiene una ictericia obstructiva, sin dolor, por lo que lo más probable es que sea un cáncer. Recordar que "adulto mayor amarillo y sin dolor" es cáncer hasta que se demuestre lo contrario. La coledocolitiasis tiene dolor. El síndrome de Gilbert y la hemólisis no tienen coluria, porque son hiperbilirrubnemias indirectas.

Fuente: Gastroenterología, prueba 1 del 21 de abril de 2024, P10

42. ¿Cuál de los siguientes es el factor de riesgo más importante para desarrollar cáncer de vesícula?

a. Antecedentes familiares de cáncer de vesícula
b. Colelitiasis
c. Consumo de alcohol
d. Obesidad
e. Tabaquismo

Respuesta correcta: b. Colelitiasis

Explicación: La colelitiasis es el factor de riesgo más importante. Por eso es que en Chile incluso se operan las colelitiasis asintomáticas. El otro factor de riesgo son las colecistitis crónicas: vesícula en porcelana, vesícula escleroatrófica, portación biliar de Salmonella typhi, etc. La colecistectomía preventiva es una prestación GES en Chile tanto en mujeres como ahora también en hombres entre 35 y 49 años diagnosticados de cáncer de vesícula. Con esto, la mortalidad por este cáncer ha disminuido sostenida e importantemente en los últimos años.

Fuente: Gastroenterología, prueba 3 del 21 de abril de 2024, P10

43. Un paciente de 40 años, con antecedente de colitis ulcerosa, consulta por astenia, asociada a ictericia. Al examen físico se constata ictericia de piel y mucosas y dolor abdominal a la palpación profunda. Se solicitan exámenes entre los que destaca GOT: 51 UI/L, GPT: 40 UI/L, bilirrubina: 6,9 mg/dl, bilirrubina directa: 6,0 mg/dl, FA: 650 UI/L, albúmina: 4,3 g/dl. El diagnóstico más probable es:

a. Cirrosis biliar primaria
b. Hepatitis autoinmune
c. Cáncer de páncreas
d. Colangitis esclerosante primaria
e. Cáncer de vesícula biliar

Respuesta correcta: d. Colangitis esclerosante primaria

Explicación: Tiene una colestasia (elevación de la bilirrubina directa, GGT y fosfatasas alcalinas). Hasta ahí puede ser cualquiera de las opciones, excepto la hepatitis autoinmune, que produce hepatitis y no colestasia. Sin embargo, el antecedente de colitis ulcerosa es muy fuerte, a favor de la colangitis esclerosante primaria (CEP), ya que es una complicación frecuente de la colitis ulcerosa y la mayoría de las CEP se producen en contexto de pacientes con colitis ulcerosa. Los síntomas más frecuentes son la astenia y el prurito (igual que en otras colestasias crónicas) y el diagnóstico se suele establecer con las pruebas hepáticas más una colangioRMN, que muestra zonas de estenosis y dilatación de la vía biliar ("arrosariamento" de la vía biliar extrahepática). La biopsia puede ayudar a confirmar el diagnóstico y, sobre todo, para ver el grado de daño hepático. El tratamiento es con ácido ursodeoxicólico como manejo sintomático. Se suelen indicar inmunosupresores, pero no han demostrado mayor eficacia. Se pueden instalar stent o realizar dilataciones con balón de la vía biliar, por acceso endoscópico. Al final, se debe trasplantar con alguna frecuencia, ya que la sobrevida promedio sin trasplante es aproximadamente de 10 años desde el diagnóstico. En esto se parece mucho a la colangitis biliar primaria (CBP). La CEP se asocia a cáncer de vesícula y vía biliar, por lo que se recomienda el control imagenológico frecuente (mínimo con ecografía e idealmente también con colangioRMN).

Fuente: Gastroenterología, prueba 3 del 21 de abril de 2024, P11

44. Paciente de sexo femenino, de 65 años, inicia dolor en Hipocondrio derecho, muy intenso, asociado a sensación febril. Al día siguiente, el dolor se hace mucho más intenso, agregándose ictericia, fiebre hasta 41°C y desorientación. La analítica sanguínea muestra Hcto: 42%, G. Blancos: 18.200, GOT: 105, GPT: 98, Bili: 6,7, amilasa normal. La ecografía abdominal muestra vesícula biliar normal colédoco de 12 mm de diámetro. El diagnóstico más probable es:

a. Colecistitis aguda
b. Pancreatitis aguda
c. Hepatitis aguda
d. Coledocolitiasis
e. Colangitis aguda

Respuesta correcta: e. Colangitis aguda

Explicación: Tiene una colangitis clínica (el diagnóstico es clínico), ya que tiene la triada de Charcot (dolor, fiebre e ictericia) y además tiene el compromiso de conciencia (de la péntada de Reynolds; falta la hipotensión). Las pruebas hepáticas muestran una colestasia y la leucocitosis da cuenta de la infección. El colédoco está dilatado (normal es hasta 7 mm, ya que hay una colédocolitiasis de base en la mayoría de las colangitis (se llaman colangitis litiásica).

Fuente: Gastroenterología, prueba 1 del 21 de abril de 2024, P12

Páncreas (3)

45. Un paciente de 66 años, alcohólico, consulta por dolor abdominal intenso, que aparece después de comer y de consumir alcohol. Los episodios de dolor se han vuelto cada vez más frecuentes y se han asociado a baja de peso. Se solicitan exámenes generales entre los que destaca glicemia de ayuno de 180 mg/dl. El diagnóstico más probable es:

a. Úlcera péptica
b. Cáncer de estómago
c. Pancreatitis crónica

d. Cáncer de páncreas
e. Angina mesentérica

Respuesta correcta: c. Pancreatitis crónica

Explicación: Es una pancreatitis crónica clásica: antecedente de alcoholismo, con clínica de dolor abdominal postprandial y postconsumo de alcohol. Además, está complicada con una probable diabetes, que son insulinorequirientes, por ser causadas por daño pancreático. - Se debe pedir una TAC de abdomen o una colangiopancretografía por RMN para confirmar el diagnóstico. En los casos en los que queda la duda, se puede usar la prueba de estimulación con secretina. - El tratamiento suele ser discontinuar el consumo de alcohol, dieta baja en grasas y analgésicos (Paracetamol o AINES y luego opiáceos, idealmente agregando moduladores del dolor como los antidepresivos IRS o duales o los gabapentoides, como la pregabalina o la gabapentina). En los casos que no responden, se realiza tratamiento invasivo con cirugía endoscópica de drenaje o cirugía abierta (como opción, en casos en que no hay obstrucción, se puede realizar un bloqueo nervioso, del plexo celíaco). - En este caso, además, se debe repetir la glicemia y , si vuelve a estar sobre 126, se confirma la diabetes y se debe iniciar insulina (no son muy eficaces los hipoglicemiantes orales en las diabetes de origen pancreático). - Finalmente, en los casos en que hay déficit exocrino, con malabsorción, se deben dar enzimas pancreáticas orales, junto con las comidas. - La angina mesentérica tiene la misma clínica, pero sin el antecedente de alcoholismo, sino con el antecedente de factores de riesgo cardiovascular. El cáncer de páncreas tiene ictericia, dolor, depresión y diabetes.

Fuente: Gastroenterología, prueba 3 del 21 de abril de 2024, P1

46. El marcador más específico del cáncer de páncreas es:

a. Ca 125
b. Ca 19.9
c. Antígeno carcinoembrionario
d. Alfafetoproteína
e. Tripsina

Respuesta correcta: b. Ca 19.9

Explicación: El Ca-19.9 es el marcador del cáncer de páncreas. - Ca 125 es marcador de cáncer de ovario y de otros procesos peritoneales, como la endometriosis. - Antígeno carcinoembrionario es marcador del cáncer de colon, aunque también se puede elevar en otros cánceres digestivos. - Alfafetoproteína es marcador de hepatocarcinoma, del cáncer testicular no seminoma y de los defectos del tubo neural (ej. espina bífida y anencefalia).

Fuente: Gastroenterología, prueba 3 del 21 de abril de 2024, P3

47. La primera causa de pancreatitis aguda en Chile es:

a. Idiopática
b. Litiásica
c. Hipertrigliceridemia
d. Alcohólica
e. Transgresión alimentaria

Respuesta correcta: b. Litiásica

Explicación: Las causas de pancreatitis aguda, en orden de importancia, son: 1. Litiasis, 2. Alcohólica y 3. Hipertrigliceridemia.

Fuente: Gastroenterología, prueba 2 del 21 de abril de 2024, P4

Enfermedad inflamatoria intestinal (3)

48. Una paciente de 30 años consulta por diarrea de 6 semanas de evolución, acompañada de intenso pujo y tenesmo y de dolor abdominal tipo cólico. Además, presenta astenia y sensación febril ocasional. La diarrea es acuosa, aunque en algunas oportunidades ha sido sanguinolenta. El diagnóstico más probable es:

a. Cáncer de colon
b. Enfermedad celíaca
c. Parasitosis intestinal
d. Colitis bacteriana
e. Colitis ulcerosa

Respuesta correcta: e. Colitis ulcerosa

Explicación: Es una enfermedad inflamatoria clásica: paciente joven, con diarrea disentérica, fiebre. Además, por no tener nada que oriente a E. de Cröhn, lo más probable es que se trate de una colitis ulcerosa (CU). Además, la CU se caracteriza por mucho pujo y tenesmo, dado que siempre comienza con una rectitis.

Fuente: Gastroenterología, prueba 2 del 21 de abril de 2024, P3

49. Un paciente de 29 años consulta por dolor abdominal de 1 mes de evolución, asociado a diarrea acuosa abundante, que en ocasiones es disentérica. Además, ha bajado de peso y al examen físico se palpa el abdomen doloroso, con una masa abdominal en el hemiabdomen inferior. El diagnóstico más probable es:

a. Cáncer de colon
b. Enfermedad de Cröhn
c. Colitis ulcerosa
d. Enfermedad celíaca
e. Amebiasis intestinal

Respuesta correcta: b. Enfermedad de Cröhn

Explicación: Tiene clínica de una enfermedad inflamatoria intestinal (paciente joven con diarrea disentérica y dolor). La presencia de una masa es indicadora de E. Cröhn y no de colitis ulcerosa. Si la pregunta hubiese sido igual, pero con un paciente de 69 años, la respuesta habría sido cáncer de colon (masa, más hemorragia, más alteración del tránsito intestinal), pero a los 29 años, es Cröhn.

Fuente: Gastroenterología, prueba 3 del 21 de abril de 2024, P4

50. Un paciente de 17 años consulta por diarrea de 2 meses de evolución, con gotas de grasa, asociada a baja de peso y dolor abdominal. En ocasiones ha presentado deposiciones con sangre. Su examen físico no aporta mayor información y sus exámenes generales de laboratorio solo muestran anemia. Se realiza una TAC de abdomen y pelvis, que muestra signos de inflamación en el íleon. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

a. Enfermedad de Cröhn
b. Parasitosis intestinal
c. Cáncer de colon
d. Colitis ulcerosa

e. Enfermedad celíaca

Respuesta correcta: a. Enfermedad de Cröhn

Explicación: Tiene un síndrome de malabsorción, sin embargo, las deposiciones con sangre y la ileítis orientan fuertemente a una enfermedad de Cröhn. La colitis ulcerosa no puede afectar al íleon, sino solo al colon.

Fuente: Gastroenterología, prueba 4 del 21 de abril de 2024, P10

Diarrea aguda e infecciones intestinales (5)

51. Identifique la asociación correcta entre la patología y su tratamiento de elección:

a. Amebiasis – albendazol
b. Giardiasis – praziquantel
c. Shiguellosis – amoxicilina
d. Diarrea por Clostridium difficile – metronidazol
e. Cólera – Cotrimoxazol

Respuesta correcta: d. Diarrea por Clostridium difficile – metronidazol

Explicación: Diarrea por Clostridium difficile (actualmente llamado Clostridioides difficile) – metronidazol o vancomicina. - Si es leve o moderada, se recomienda comenzar con metronidazol oral por 14 días. - Si es severa (falla renal, hipoalbuminemia severa, blancos >15.000 por mm3), se prefiere iniciar directamente con vancomicina oral por 10 días (por ser más afectiva y tener menos resistencia; de hecho, en países en que hay mucha resistencia, se recomienda la vancomicina o la fidaxomicina como tratamiento de primera línea en los casos leves también, pero este no es el caso de Chile, por ahora). - Si, además de ser severa, está complicada (perforación, megacolon, shock, íleo paralítico), se prefiere el uso combinado de metronidazol endovenoso más vancomicina oral (no llega bien al intestino cuando se da endovenosa; en el caso de íleo, que contraindique la vía oral, se puede dar vía rectal). - En las recurrencias, 1. se repite el antibiótico dado inicialmente, 2. si recurre, se recomienda vancomicina en dosis crecientes, 3. Si recurre por tercera vez, se recomienda vancomicina por periodos prolongados, seguido de rifaximina y se empieza a evaluar el trasplante fecal. * Sobre el diagnóstico, actualmente se prefiere la PCR para C. difficile sobre la detección de toxinas en deposiciones. Lo correcto en las demás opciones es: 1. Amebiasis – metronidazol (sirve también tinidazol). 2. Giardiasis – tinidazol (sirve también metronidazol y nitazoxanida). 3. Shiguellosis – ciprofloxacino (sirve también azitromicina y cefalosporinas de tercera generación: cefixima oral o ceftriaxona endovenosa, en los casos graves). 4. Cólera – Azitromicina o doxiciclina (sirve también ciprofloxacino).

Fuente: Gastroenterología, prueba 1 del 21 de abril de 2024, P4

52. Una paciente de 28 años presenta un cuadro de diarrea acuosa, de 5 días de evolución, asociado a dolor abdominal tipo cólico. Refiere que presentó sensación febril durante el primer día y también vómitos alimentarios en un par de ocasiones. El diagnóstico más probable es:

a. Colitis parasitaria
b. Colitis viral
c. Colitis bacteriana
d. Colitis ulcerosa
e. Colitis pseudomembranosa

Respuesta correcta: b. Colitis viral

Explicación: Tiene una diarrea aguda (menos de 14 días), por lo que lo más probable es que sea viral. No tiene disentería, como para pensar en bacterias. Los vómitos y el dolor tipo cólico, son parte del cuadro clínico habitual. También la fiebre de corta duración. Por lo mismo, el uso de antibióticos no está indicado en la inmensa mayoría de los adultos con diarrea aguda, ya que, incluso si es bacteriana, suelen ser cuadros autolimitados. Solo se indican en casos de disentería o cuando hay ciertas situaciones epidemiológicas o sospechas de infecciones específicas (ej. diarrea del viajero, C. difficile, demostración de Shigella, cólera, cuadros sépticos, fiebre tifoidea).

Fuente: Gastroenterología, prueba 1 del 21 de abril de 2024, P5

53. Un niño de 4 años presenta un cuadro de diarrea de 2 días de evolución, asociado a fiebre hasta 38°C y vómitos. Al examen físico se aprecia hidratado, con el abdomen sensible y con aumento de los ruidos hidroaéreos. La conducta más adecuada es:

a. Indicar hidratación oral, sin necesidad de estudio
b. Solicitar coprocultivo
c. Solicitar colonoscopía
d. Solicitar ecografía abdominal
e. Solicitar parasitológico seriado de deposiciones

Respuesta correcta: a. Indicar hidratación oral, sin necesidad de estudio

Explicación: Es una diarrea aguda en un niño. Lo único que importa es el grado de deshidratación. En este caso, por estar hidratado, basta el plan A: sales de rehidratación oral 100 a 200 cc, después de cada deposición diarreica. Aunque tenga fiebre, lo más probable es que sea viral. Los antibióticos (ciprofloxacino, cefixime o azitromicina; ceftriaxona en casos muy graves) solo se indican en casos de disentería, diarreas febriles con mucho compromiso del estado general o situaciones epidemiológicas específicas (diarrea del viajero: ciprofloxacino; cólera: doxiciclina, azitromicina o ciprofloxacino; fiebre tifoidea: ciprofloxacino de elección o ceftriaxona).

Fuente: Gastroenterología, prueba 3 del 21 de abril de 2024, P7

54. Un paciente de 17 años consulta por diarrea acuosa abundante de 6 días de evolución, asociada a dolor abdominal tipo cólico. No ha presentado fiebre, ni disentería, pero está muy preocupado porque lleva muchos días con los síntomas. Al examen físico está hidratado, con abdomen blando y depresible, doloroso a la palpación profunda, sin signos de irritación peritoneal y con aumento de los ruidos intestinales. La conducta más adecuada es:

a. Solicitar colonoscopía
b. Solicitar coprocultivos y parasitológico de deposiciones e indicar hidratación oral
c. Indicar hidratación oral y observar evolución, sin necesidad de otros medicamentos ni exámenes
d. Indicar hidratación oral e iniciar ciprofloxacino oral
e. Indicar hidratación oral e iniciar loperamida y metronidazol por vía oral

Respuesta correcta: c. Indicar hidratación oral y observar evolución, sin necesidad de otros medicamentos ni exámenes

Explicación: Tiene una diarrea aguda, sin ningún signo de alarma. Solo se debe hidratar (o mantener hidratado si es que no hay deshidratación) y, a lo más, se le indican antieméticos y antiespasmódicos, si es que hay vómitos o dolor, respectivamente (su utilidad es restringida y lo fundamental es la hidratación). No están indicados los antidiarreicos ni los antibióticos (a menos que tenga disentería o más de 2 días con fiebre o algún antecedente especial, como la diarrea del viajero, el cólera, la fiebre tifoidea o infección por Clostridioides difficile). La colonoscopía es el estudio de la diarrea crónica (mayor a 28 días) o con signos

de alarma (ej. sospecha de enfermedad inflamatoria intestinal). El estudio microbiológico es la conducta ante la diarrea prolongada (mayor a 14 días) y también se hace en la diarrea crónica, si es que no ha consultado antes.

Fuente: Gastroenterología, prueba 2 del 21 de abril de 2024, P9

55. Cuatro horas después de acudir a un banquete, 25 personas inician súbitamente un cuadro de náuseas, vómitos y dolores abdominales. ¿Cuál de los siguientes agentes es el causante más probable de estos síntomas?

a. Clostridium botulinum
b. Salmonella
c. Escherichia coli enterotoxigénica
d. Estafilococo áureo
e. Shigella

Respuesta correcta: d. Estafilococo áureo

Explicación: Es una clásica intoxicación por enterotoxina estafilocócica: pocas horas después de comer, con mucho vómito. La Salmonella produce una diarrea febril, que suele empezar 24 a 48 horas después. El botulismo presentaría parálisis flácida y arrefléctica. La ECET produce una diarrea acuosa abundante, que suele empezar 24 a 48 horas después. La Shigella produce una diarrea disentérica, que suele empezar algunos días después.

Fuente: Gastroenterología, prueba 1 del 21 de abril de 2024, P20

Síndrome de intestino irritable y trastornos funcionales (3)

56. Un paciente de 25 años consulta porque desde hace algunos años presenta deposiciones frecuentes, 3 a 5 veces al día, formadas y de consistencia blanda. Su dieta es rica en frutas y verduras, consume una copa de alcohol al día y 3 tazas de café. No ha presentado sangre, grasa ni otros elementos patológicos y no ha tenido otros síntomas. Su examen físico es normal. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

a. Solicitar anticuerpos anti-transglutaminasa y endoscopía digestiva alta
b. Educar, recomendar disminuir el consumo de café y controlar ambulatoriamente
c. Erradicar Helicobacter pylori
d. Solicitar parasitológico de deposiciones
e. Solicitar colonoscopía

Respuesta correcta: b. Educar, recomendar disminuir el consumo de café y controlar ambulatoriamente

Explicación: La frecuencia normal de deposiciones varía entre 3 veces al día y una vez cada 3 días, siempre que su consistencia se normal (no diarreicas ni caprinas ni muy duras). En este caso, la clínica orienta a un trastorno digestivo funcional, por lo que lo fundamental es educar. Además, por tener un desencadenante identificado, la cafeína, es recomendable disminuir su consumo y reevaluar la respuesta. Actualmente el manejo del síndrome de intestino irritable (SII) siempre comienza con una buena relación médico paciente más cambio en los hábitos dietéticos (especialmente evitar alimentos que generan muchos gases, moderar consumo de café y similares), más manejo de los estresores. Si hay constipación, se puede iniciar Psyllum (un laxante natural, recomendado por varías guías internacionales). Los fármacos no se recomiendan como primera línea en el manejo del SII, pero, en caso de que no responda al manejo inicial, se tratan según los síntomas más importantes: - Dolor: se puede manejar con antiespasmódicos, como el trimebutino y, de segunda línea, se agregan antidepresivos IRS o duales (van desde el inicio si, además, tiene depresión). - Constipación: Psyllum y luego laxantes osmóticos, como el polietilenglicol (PEG). -

Diarrea: antidiarreicos (ej. loperamida); también sirven los antidepresivos tricíclicos, si es joven y tiene dolor, ya que son antidiarreicos y moduladores del dolor.

Fuente: Gastroenterología, prueba 4 del 21 de abril de 2024, P7

57. ¿Cuál de las siguientes alteraciones es MENOS sugerente de un síndrome de intestino irritable?

a. Pujo y tenesmo
b. Diarrea con mucosidad
c. Dolor abdominal con exacerbaciones tipo cólico
d. Distensión abdominal
e. Edad de 20 años

Respuesta correcta: a. Pujo y tenesmo

Explicación: El pujo y tenesmo son signos de organicidad. Están especialmente frecuentes en la colitis ulcerosa y en las colitis infecciosas, así como en todas las rectitis (ej. actínica). Recordar el ABCDEFGHN de la gastroenterología, más la fiebre y signos de malabsorción. Las demás opciones son perfectamente compatibles con un síndrome de intetsino irritable.

Fuente: Gastroenterología, prueba 3 del 21 de abril de 2024, P9

58. ¿Qué hallazgo o antecedente es MENOS orientador a un trastorno digestivo funcional?

a. Pujo y tenesmo
b. Distensión abdominal
c. Dolor abdominal tipo cólico
d. Constipación
e. Diarrea

Respuesta correcta: a. Pujo y tenesmo

Explicación: El pujo y tenesmo son indicadores de organicidad (se ve en la colitis ulcerosa, en las colitis infecciosas, en otras rectitis, como la actínica). Las demás opciones son del todo compatibles con un síndrome de intestino irritable. Algunos otros indicadores de organicidad son anemia, baja de peso, cambio en los síntomas, disfagia, edad mayor a 50 años, hemorragias, lientería, esteatorrea, fiebre.

Fuente: Gastroenterología, prueba 1 del 21 de abril de 2024, P16

Malabsorción y enfermedad celíaca (5)

59. ¿Cuál de los siguientes alimentos puede ser ingerido libremente por los pacientes con enfermedad celíaca?:

a. Carne de cerdo
b. Galletas
c. Tallarines
d. Pan
e. Avena

Respuesta correcta: a. Carne de cerdo

Explicación: No pueden consumir trigo, cebada, centeno, ni avena. Tampoco alimentos procesados, que puedan contener los 4 granos descritos. Pueden comer carne de todos los animales.

Fuente: Gastroenterología, prueba 1 del 21 de abril de 2024, P11

60. Un paciente de 15 años, con antecedente de diarrea crónica desde la infancia, no estudiada, consulta por astenia y debilidad. En sus exámenes generales se constata anemia ferropénica y se solicita test de Sudán que muestra esteatorrea +++. La conducta más adecuada es:

a. Solicitar colonoscopía
b. Solicitar endoscopía digestiva alta y anticuerpos antitransglutaminasa
c. Solicitar TAC de abdomen
d. Solicitar lipasa plasmática
e. Solicitar tripsina de deposiciones

Respuesta correcta: b. Solicitar endoscopía digestiva alta y anticuerpos antitransglutaminasa

Explicación: La sospecha es una enfermedad celíaca, ya que tiene malabsorción confirmada con la prueba de Sudán (objetiva la esteatorrea) y porque además hay anemia ferropénica. La endoscopía y los anticuerpos antitransglutaminasa (anti-TGT) son la forma en que se estudia la enfermedad celíaca. También habría sido correcto continuar el estudio con el test de D-xilosa, ya que suele pedirse en los pacientes con malabsorción para determinar el origen de la malabsorción (si es parietal, se altera la prueba de D-xilosa; si es un problema enzimático, está normal la prueba de D-xilosa), sin embargo, cuando hay una sospecha clara sobre la etiología, lo recomendado actualmente es realizar dirigidamente los exámenes confirmatorios de la patología sospechada, en este caso, el estudio específico de la enfermedad celíaca.

Fuente: Gastroenterología, prueba 3 del 21 de abril de 2024, P12

61. ¿Cuál de las siguientes parasitosis suele simular a un síndrome de malabsorción intestinal?

a. Hidatidosis
b. Anisakiasis
c. Ascariasis
d. Distomatosis
e. Giardiasis

Respuesta correcta: e. Giardiasis

Explicación: La giardiasis emula un síndrome de malabsorción. De hecho, debe ser descartada en todo síndrome de malabsorción. La hidatidosis suele ser asintomática. La anisakiasis produce vómitos y dolor abdominal después de comer pescado crudo. La ascariasis produce el síndrome de Löeffler (tos, fiebre y eosinofilia) y luego molestias intestinales inespecíficas. La distomatosis produce ictericia, fiebre y eosinofilia.

Fuente: Gastroenterología, prueba 2 del 21 de abril de 2024, P15

62. Respecto a la enfermedad celiaca es VERDADERO que:

a. Los pacientes celíacos no pueden ingerir ningún tipo de cereal
b. Su manifestación cutánea típica es el eritema nodoso
c. Aumenta el riesgo de linfoma intestinal
d. Los anticuerpos característicos de esta enfermedad son los ANCA y los ASCA
e. Su tratamiento incluye el uso de corticoides e inmunomoduladores

Respuesta correcta: c. Aumenta el riesgo de linfoma intestinal

Explicación: Uno de los riesgos de la enfermedad celíaca, es su asociación a linfoma tipo MALT (linfoma T asociado a mucosas). Pueden ingerir cualquier cereal que no sea trigo, cebada, centeno y avena. Su

manifestación cutánea es la dermatitis herpetiforme. El eritema nodoso es de las enfermedades inflamatorias intestinales. Los anticuerpos son los anti-TGT y los antiendomisio. Los ANCA son de la colitis ulcerosa, de las vasculitis y de la colangitis esclerosante primaria. Los ASCA son de la enfermedad de Cröhn.

Fuente: Gastroenterología, prueba 2 del 21 de abril de 2024, P16

63. La resección del íleon distal produce malabsorción de:

a. Vitamina B12 y ácidos biliares
b. Hierro y calcio
c. Grasas y polipéptidos
d. Vitaminas hidrosolublres
e. Polisacáridos

Respuesta correcta: a. Vitamina B12 y ácidos biliares

Explicación: Tanto la vitamina B12, como los ácidos biliares se absorben en el íleon distal. De hecho, la anemia por déficit de B12 se produce tanto las cirugías gástricas (ahí se produce el factor intrínseco, que se debe unir a la B12 para ser absorbida), como de íleon distal (ahí es donde se absorbe el complejo factor intrínseco- B12). La falta de ácidos biliares se traduce en malabsorción de lípidos y vitaminas liposolubles. El hierro y calcio se absorben en el duodeno, por lo que su absorción se afecta especialmente en la enfermedad celíaca.

Fuente: Gastroenterología, prueba 1 del 21 de abril de 2024, P19

Patología colorrectal (5)

64. Una paciente de 50 años consulta por molestias abdominales bajas, asociada a constipación. Refiere que los síntomas iniciaron hace cerca de dos meses y que no identifica ningún gatillante, ya que ha mantenido su dieta y demás hábitos. Previo a ello, evacuaba deposiciones normales 1 o 2 veces al día. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

a. Solicitar examen parasitológico de deposiciones
b. Aumentar el consumo de agua y fibra y controlar ambulatoriamente
c. Iniciar trimebutino oral
d. Iniciar amitriptilina oral
e. Solicitar colonoscopía

Respuesta correcta: e. Solicitar colonoscopía

Explicación: Por la edad y por el cambio en el hábito intestinal se debe descartar un cáncer de colon con una colonoscopía completa (aprenderse el ABCDEFGH-N completo). Si bien es correcto aumentar el consumo de agua y fibra, lo más importante es pedir la colonoscopía. La amitriptilina aumenta la constipación. El trimebutino es un antiespasmódico, que se puede usar en el síndrome de intestino irritable con dolor, pero ese no es el caso, ya que el SII suele iniciar antes de los 35 años.

Fuente: Gastroenterología, prueba 4 del 21 de abril de 2024, P2

65. Un paciente de 60 años consulta por constipación de 2 meses de evolución. Su examen físico es normal y en sus exámenes destaca anemia microcítica. La conducta más adecuada es:

a. Solicitar TAC de abdomen y pelvis
b. Solicitar colonoscopía con preparación de colon

c. Solicitar ecografía abdominal
d. Solicitar radiografía de abdomen simple en dos posiciones
e. Iniciar dieta rica en fibra y observar evolución

Respuesta correcta: b. Solicitar colonoscopía con preparación de colon

Explicación: Por un lado, tiene una sospecha de cáncer de colon, la que se estudia con colonoscopía. Por otro lado, tiene una constipación con dignos de alarma: inicio después de los 50 años y anemia, por lo que también se debe estudiar con colonoscopía. Se debe recordar que existen varios test para detectar el cáncer de colon. De ellos, el mejor es la colonoscopía completa, ya que ve todo el colon y, además, es buena para detectar no solo el cáncer, sino también lesiones premalignas, como los pólipos adenomatosos (se resecan estos durante la misma colonoscopía; el cáncer no se reseca en la colonoscopía, sino con una hemicolectomía como mínimo). Otros test, incluyen la rectosigmoidoscopía, que es más sencillo y barato de hacer (no requiere sedación), pero solo evalúa el colon izquierdo. Finalmente existen las pruebas de detección de sangre oculta en deposiciones, que han mejorado mucho en los últimos años (ahora se llaman "ultrasensibles") y que son efectivamente bastante sensibles, además de ser muchísimo más baratas que la colonoscopía. Sin embargo, no detectan a los pólipos adenomatosos ni superan a la colonoscopía. Por tanto, su utilización se reserva a aquellos casos en que se quiere hacer un screening en un paciente asintomático, en un contexto en que no existen recursos para una colonoscopía o hay alguna razón para no hacerla (ej. el paciente no quiere hacerse una colonoscopía). Si está alterado, se debe realizar la colonoscopía. En este caso, por estar con síntomas, es obligatoria la colonoscopía y no se deben hacer las otras pruebas de detección de cáncer de colon.

Fuente: Gastroenterología, prueba 3 del 21 de abril de 2024, P14

66. Un paciente de 66 años presenta un cuadro de constipación marcada de 3 días de evolución, sin poder presentar deposiciones, asociado a dolor abdominal. Luego presenta deposiciones diarreicas explosivas en una oportunidad. Refiere además historia de palidez y molestias abdominales de 1 mes de evolución. El examen físico muestra un paciente pálido, con abdomen blando, depresible y el tacto rectal demuestra una ampolla rectal sin deposiciones, sin hallar otras alteraciones. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

a. Vólvulo de colon sigmoides
b. Cáncer de colon
c. Obstrucción intestinal por bridas
d. Síndrome de Ogilvie
e. Diverticulitis

Respuesta correcta: b. Cáncer de colon

Explicación: Es un cáncer de colon clásico, complicado con una obstrucción parcial. Adulto mayor con constipación obliga a descartar cáncer de colon, más aún si se asocia a anemia (palidez). El vólvulo se presenta como una obstrucción aguda y en la radiografía se observa la imagen en "grano de café". La obstrucción por bridas, se da en pacientes con antecedente de cirugías abdominales y también dan obstrucción aguda. El síndrome de Ogilvie es una pseudo-obstrucción aguda de colon, con la misma clínica que una obstrucción común y corriente, pero sin una causa mecánica de obstrucción. La etiología es desconocida, el diagnóstico se realiza con la TAC de abdomen (que suele mostrar dilatación del colon, con una zona de transición contraída, habitualmente a la altura del ángulo esplénico del colon, sin una causa que explique la obstrucción. El manejo consiste en 1. descartar las otras causas de obstrucción, dar terapia conservativa (es lo más habitual); 2. si no responde en tres días máximo o si el diámetro del colon es mayor a 12 cm, se da neostigmina; 3. si no responde, se hace descomprensión del colon, mediante colonoscopía; y 4. si se perfora o hay isquemia intestinal, recién se opera (pero es la excepción).

Fuente: Gastroenterología, prueba 1 del 21 de abril de 2024, P17

67. Un paciente de 70 años consulta por dolor abdominal intenso, asociado a sensación febril. El dolor inició hace 5 horas, en la fosa iliaca izquierda y se ha vuelto más intenso. Al examen físico se aprecia dolor a la palpación de la FII y signo de Blumberg en dicha zona. El diagnóstico más probable es:

a. Cáncer de colon
b. Diverticulitis aguda
c. Colitis isquémica
d. Íleo biliar
e. Enfermedad de Cröhn

Respuesta correcta: b. Diverticulitis aguda

Explicación: Es una diverticulitis clásica, cuyo diagnóstico es clínico y se basa en el dolor con irritación peritoneal en la fosa ilíaca izquierda. Se estudia con un TAC para determinar la gravedad y el manejo y, según algunos autores, también para confirmar el diagnóstico (sin embargo, el diagnóstico es predominantemente clínico). El íleo biliar suele presentarse como una obstrucción intestinal, que en la radiografía se ve con neumobilia y presencia de un cálculo en un asa intestinal, habitualmente, en el íleon distal. Puede estar precedido de dolor en el hipocondrio derecho (por la colecistitis que da origen a la fístula colecistoduodenal, a través de la que pasa el cálculo al intestino).

Fuente: Gastroenterología, prueba 2 del 21 de abril de 2024, P18

68. Una paciente de 80 años consulta por dolor abdominal intenso, asociado sensación febril. El dolor inició hace 8 horas y actualmente se localiza en la fosa iliaca izquierda. Es de carácter sordo, intensidad constante, aunque ha aumentado con el pasar de las horas. Al examen físico presenta dolor intenso a la palpación abdominal, con signo de Blumberg en la fosa iliaca izquierda. ¿Cuál es la medida MENOS indicada en este paciente?

a. Administrar AINES
b. Solicitar colonoscopía
c. Iniciar antibióticos
d. Administrar suero fisiológico
e. Solicitar hemograma

Respuesta correcta: b. Solicitar colonoscopía

Explicación: Es una diverticulitis clásica, cuyo diagnóstico es clínico y se basa en el dolor con irritación peritoneal en la fosa ilíaca izquierda. Se estudia con un TAC para determinar la gravedad y el manejo (según algunos autores la TAC también confirma el diagnóstico, mientras que para otros el diagnóstico sigue siendo clínico. De todos modos, la TAC siempre se debe pedir, por lo que la discusión no tiene mayor importancia). En cambio, la colonoscopía está absolutamente contraindicada, ya que puede producir una perforación. Vale la pena recalcar, que en la enfermedad diverticular no complicada y en la complicada con una hemorragia digestiva baja, la colonoscopía no solo que no está contraindicada, sino que es el examen de elección. Solo en la diverticulitis aguda sí está contraindicada.

Fuente: Gastroenterología, prueba 3 del 21 de abril de 2024, P19

Isquemia mesentérica (2)

69. Un paciente de 67 años, con antecedente de hipertensión arterial y palpitaciones recurrentes, presenta un cuadro de dolor abdominal muy intenso, de localización difusa, que comenzó hace 1 hora y se

ha mantenido en 10/10. Además, presentó vómitos y deposiciones en varias oportunidades. Su examen físico muestra signos vitales normales y su examen abdominal muestra un abdomen blando, sin signos de irritación peritoneal. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

a. Realizar endoscopía digestiva alta urgente
b. Realizar laparotomía exploradora de inmediato
c. Administrar antiespasmódicos y analgésicos por vía endovenosa y evaluar respuesta en 20 a 30 minutos
d. Solicitar TAC de abdomen y pelvis urgente
e. Solicitar angioTAC de abdomen urgente

Respuesta correcta: e. Solicitar angioTAC de abdomen urgente

Explicación: La sospecha es una embolia mesentérica, dado el inicio súbito muy intenso y el examen abdominal sin signos peritoneales en las primeras horas (la clásica disociación entre la intensidad del dolor y la normalidad del examen abdominal). Por tanto, se debe estudiar con angioTAC (sin contraste intestinal, pero con contraste endovenoso y técnica de angiografía por TAC) urgente o una angiografía mesentérica, siendo actualmente de elección la angioTAC si está disponible para ser realizada e informada de inmediato. La historia de palpitaciones previas sugiere una fibrilación auricular. La isquemia mesentérica suele asociarse a acidosis metabólica con mucha frecuencia. En los casos en que la isquemia mesentérica progresa a signos peritoneales (no es este caso) y se sospecha que hay un infarto intestinal irrecuperable o una perforación, se va directamente a una laparotomía exploradora, sin siquiera solicitar el angioTAC. La revascularización clásicamente se hace con cirugía abierta, pero también se puede hacer por vía endovascular.

Fuente: Gastroenterología, prueba 4 del 21 de abril de 2024, P9

70. La angina mesentérica se presenta semiológicamente como:

a. Dolor abdominal intenso, de inicio súbito, asociado a hematoquezia
b. Dolor abdominal postprandial, asociado a baja de peso
c. Dolor abdominal postprandial, asociado a diabetes y malabsorción intestinal
d. Dolor abdominal que aumenta en periodos de ayunas
e. Dolor abdominal que aparece al realizar actividad física y que cede con el reposo

Respuesta correcta: b. Dolor abdominal postprandial, asociado a baja de peso

Explicación: - La A es una embolia mesentérica o una colitis isquémica: Dolor abdominal intenso, de inicio súbito, asociado a hematoquezia. - La B (correcta) es una angina mesentérica: Dolor abdominal postprandial, asociado a baja de peso. - La C es una pancreatitis crónica: Dolor abdominal postprandial, asociado a diabetes y malabsorción intestinal. - La D es un síndrome ulceroso: Dolor abdominal que aumenta en periodos de ayunas. - La E es una angina cardíaca, de pared inferior: Dolor abdominal que aparece al realizar actividad física y que cede con el reposo.

Fuente: Gastroenterología, prueba 2 del 21 de abril de 2024, P14

Nefrología (117)

Insuficiencia renal aguda (19)

1. Un paciente cursando una sepsis grave, tratada con antibióticos endovenosos, evoluciona con elevación de la creatinina. En sus exámenes destaca creatinina de 5,0 mg/dl, sodio plasmático: 125 mg/dl, sodio urinario: 20 mg/dl y creatinina urinaria: 15 mg/dl. En el sedimento de orina presenta abundantes cilindros, sin hematuria. El diagnóstico más probable es:

a. Necrosis tubular aguda
b. Glomerulonefritis postinfecciosa
c. Insuficiencia renal aguda prerrenal
d. Síndrome hemolítico urémico
e. Síndrome nefrótico impuro

Respuesta correcta: a. Necrosis tubular aguda

Explicación: Tiene una IRA (creatinina elevada), de tipo renal, porque el Na+ urinario está mayor o igual a 20 mEq/L. Además la FeNa (fracción excretada de sodio) se podría calcular y resulta mayor a 1%. FeNa = (UNa / PNa) / (PCr / UCr) FeNa = (20 / 125) / (15 / 5) = 0,053 = 5,3% Sin embargo, no es necesario calcularla, para no perder tiempo y basta con ver el sodio urinario. Finalmente que haya abundantes cilindros orienta a NTA, ya que se caracteriza por cilindros céreos y granulosos y también por la presencia de células epiteliales tubulares. - La B (GN postinfecciosa) cursa con hematuria dismórfica. - La C (IRA prerrenal) tiene sodio urinario menor a 10 mEq/L y FeNa menor a 1% y con sedimento de orina normal. - La D (SHU) suele tener el antecedente de diarrea y cursa con IRA severa, más trombopenia y anemia hemolítica. - La E (síndrome nefrótico impuro) requeriría proteinuria, más hipoalbuminemia, dislipidemia, edema y lipiduria.

Fuente: Nefrología, cuestionario 5.3, P5

2. Un paciente de 45 años, cursando una necrosis tubular aguda, presenta compromiso de conciencia, con desorientación y sopor, asociado a asterixis. No presenta focalidad neurológica y se constata creatininemia: 5,6 mg/min, BUN: 100 mg/dl, K+: 6,0 mEq/L, Na+: 130 mEq/L. La conducta más adecuada es:

a. Solicitar gases venosos y decidir conducta según resultado
b. Iniciar haloperidol en dosis bajas
c. Administrar suero hipertónico endovenoso
d. Administrar suero fisiológico endovenoso
e. Realizar hemodiálisis de urgencia

Respuesta correcta: e. Realizar hemodiálisis de urgencia

Explicación: Tiene una NTA con IRA grave, ya que cursa con un síndrome urémico, con presencia de encefalopatía urémica (compromiso de conciencia, asterixis). El síndrome urémico es indicación de hemodiálisis de urgencia. La otra indicación son las complicaciones graves que no responden a tratamiento médico (ej. hiperkalemia grave o edema pulmonar que no se logren estabilizar con fármacos). Finalmente, el BUN mayor a 100 mg/dl es una indicación relativa, ya que habitualmente se asocia a síndrome urémico, como en este caso, aunque no todos los autores aceptan la diálisis de urgencia en pacientes con BUN mayor a 100, pero sin síntomas de uremia.

Fuente: Nefrología, cuestionario 5.3, P13

3. Son indicaciones de hemodiálisis de urgencia, en contexto de un paciente cursando una insuficiencia renal aguda, EXCEPTO

a. Anuria de 24 horas de evolución
b. Hiperkalemia grave, refractaria a tratamiento médico
c. Edema pulmonar grave, que no responde a tratamiento vasodilatador y diurético
d. Pericarditis urémica
e. Encefalopatía urémica

Respuesta correcta: a. Anuria de 24 horas de evolución

Explicación: Las indicaciones de HD de urgencia en la insuficiencia renal aguda de cualquier causa y también en la crónica, son 1. el síndrome urémico (alternativas D y E) y 2. las complicaciones graves que no responden a tratamiento médico (alternativas B y C). En cambio, la anuria de 24 horas no significa nada en especial, más allá de que probablemente cursa con una IRA grave.

Fuente: Nefrología, cuestionario 5.4, P2

4. Un niño de 4 años, cursando una diarrea aguda, evoluciona con oliguria y deterioro del estado general. Posteriormente convulsiona en una oportunidad. Al examen físico está decaído, con edema y palidez de piel e ictericia de escleras. El diagnóstico más probable es:

a. Glomerulonefritis postestreptocócica
b. Glomerulonefritis rápidamente progresiva
c. Necrosis tubular renal
d. Insuficiencia renal aguda prerrenal
e. Síndrome hemolítico urémico

Respuesta correcta: e. Síndrome hemolítico urémico

Explicación: Es un SHU clásico, ya que afecta a niños (lo más frecuente que sean prescolares), cursando con una insuficiencia renal grave, asociada a hemólisis, plaquetopenia y compromiso del SNC. Además, suele venir precedido por diarrea o disentería por E. coli enterohemorrágica o Shigella. En este caso, la oliguria y el edema son síntomas de la insuficiencia renal aguda. La palidez y la ictericia son sugerentes de la hemólisis. Las convulsiones muestran la afectación del SNC. - La A (GNAPE) es un síndrome nefrítico, 1 a 2 semanas luego de una amigdalitis. - La B (GNRP) es una GN con IRA grave. En este caso falta la hematuria dismórfica, como para pensar en una glomerulonefritis. Además, la clínica es clásica de SHU. - La D (prerrenal) suele tener hemoconcentración, elevación de las plaquetas, signos de deshidratación (no edema).

Fuente: Nefrología, cuestionario 5.4, P6

5. Un paciente cursando una insuficiencia renal aguda, presenta sodio urinario de 40 mEq/L y creatinina de 3,8 mg/dl, con un sedimento de orina sin hematuria, con algunos cilindros hialinos y granulosos. El diagnóstico más probable es:

a. Insuficiencia renal prerrenal por deshidratación
b. Insuficiencia renal prerrenal por uso de furosemida
c. Insuficiencia renal prerrenal por uso de tiazídicos
d. Nefritis intersticial
e. Necrosis tubular aguda

Respuesta correcta: e. Necrosis tubular aguda

Explicación: Tiene una IRA de tipo renal, porque el sodio urinario está mayor a 20 mEq/L. Con ello se descartan las opciones A, B y C. La presencia de cilindros granulosos sugiere una NTA (los hialinos son normales). En cambio, la nefritis intersticial tiene eosinófilos en el sedimento.

Fuente: Nefrología, cuestionario 5.4, P8

6. ¿Cuál es la medida más importante, para evitar la nefrotoxicidad por medio de contraste?

a. Administrar suero fisiológico antes y después del examen radiológico
b. Administrar N-acetil-cisteína
c. Alcalinizar la orina, mediante administración de bicarbonato de sodio
d. Administrar un diurético de asa, para forzar la diuresis
e. Administrar el medio de contraste de manera rápida, en un solo pulso

Respuesta correcta: a. Administrar suero fisiológico antes y después del examen radiológico

Explicación: De todas las medidas, la más eficaz es administrar suero fisiológico antes de administrar el medio de contraste. Sin embargo, también sirve administrarlo después (habitualmente se da antes y despues). La N-acetil-cisteína no ha mostrado utilidad. No todos los pacientes requiere profilaxis, sino solo aquellos con IRA o con una IRC con clearence menor a 30 ml/min o que tienen factores de riesgo (edad, proteinuria, diabetes, hipertensión, insuficiencia cardíaca) y clearence menor a 45 ml/min. En sanos el riesgo del contraste es prácticamente cero. Eso sí, siempre se debe evitar realizar exámenes que no están indicados, evitar dar contraste cuando el examen sin contraste es suficiente y, en pacientes que tienen muy alto riesgo, preferir otros exámenes sin uso de contraste. Por el contrario, en casos en que están muy graves y que requieren del examen urgentemente, se debe proceder a realizarlo, sin esperar a administrar el suero fisiológico.

Fuente: Nefrología, cuestionario 5.4, P10

7. Un paciente presenta una insuficiencia cardíaca crónica, la que evoluciona con un edema pulmonar, el que es manejado en el servicio de urgencia. Se administra oxígeno y furosemida endovenosa, logrando resolución del cuadro, sin embargo, evoluciona con oliguria, constatándose, al día siguiente, una creatinina plasmática de 3,6 mg/dl. La causa más probable de la elevación de la creatininemia es:

a. Insuficiencia renal aguda de tipo prerrenal
b. Necrosis tubular aguda
c. Nefritis intersticial
d. Rabdomiólisis
e. Síndrome riñón pulmón

Respuesta correcta: a. Insuficiencia renal aguda de tipo prerrenal

Explicación: Si bien puede tener más de una causa, el antecedente de haberle administrado diuréticos, es muy sugerente de que se volvió hipovolémico y por ello evolucionó a una IRA prerrenal. Además, la misma insuficiencia cardíaca tiene riesgo de IRA de tipo prerrenal. La B (NTA) tendría cilindros granulosos o céreos y clínicamente puede ser igual, excepto que tiene una fase poliúrica, algunos días después. La C (nefritis intersticial) puede ser secundaria a fármacos, pero tiene una clínica de fiebre, exantema y eosinofilia. La D (rabdomiólisis) suele ser después de ejercicio intenso, shock eléctrico, convulsiones o traumatismos y se caracteriza por una IRA con elevación marcada de las CK (se trata con SF ev). La E (Sd. Riñón-pulmón) es una glomerulonefritis, habitualmente GNRP, más alveolitis hemorrágica, disnea, etc.

Fuente: Nefrología, cuestionario 5.5, P1

8. Un paciente presenta una necrosis tubular aguda grave, evolucionando con hiperkalemia severa, la que no responde al tratamiento médico habitual con insulina y salbutamol, persistiendo con K: 8,0 y alteraciones electrocardiográficas. La conducta más adecuada es:

a. Administrar sulfato de magnesio endovenoso
b. Instalar marcapasos externo transitorio
c. Realizar hemodiálisis de urgencia
d. Administrar bicarbonato de sodio endovenoso
e. Administrar noradrenalina por vía endovenosa en bomba de infusión continua

Respuesta correcta: c. Realizar hemodiálisis de urgencia

Explicación: Las indicaciones de hemodiálisis de urgencia son dos: 1. Síndrome urémico y 2. Complicaciones graves que no responden a tratamiento médico (como en este caso, que tiene una hiperkalemia grave, que no respondió al tratamiento habitual). Por tanto, la C es la correcta. El $MgSO_4$ (A) se usa en la eclamsia y preclamsia severa. El MPET (B) se usa en las bradiarritmias con compromiso hemodinámico. El $NaHCO_3$ (D) se usa en la acidosis metabólica grave. La noradrenalina (E) se usa en el shock séptico y medular, además del shock que no responde a volumen.

Fuente: Nefrología, cuestionario 5.5, P7

9. Un paciente es diagnosticado de una endocarditis bacteriana, la que es tratada con cloxacilina + ampicilina + gentamicina por vía endovenosa. Inicialmente evoluciona con oligoanuria, por lo que recibe suero fisiológico por vía endovenosa. Una semana después orina cerca de 3 litros al día, sin embargo, se constata creatininemia de 3,5 mg/dl. En sus exámenes destaca Na urinario de 26 mEq/L y sedimento de orina con abundantes cilindros granulosos. El diagnóstico más probable es:

a. Glomerulonefritis aguda
b. Síndrome hemolítico urémico
c. Insuficiencia renal aguda de tipo prerrenal
d. Nefritis intersticial
e. Necrosis tubular aguda

Respuesta correcta: e. Necrosis tubular aguda

Explicación: Con los antecedentes de endocarditis y uso de antibióticos, puede ser cualquiera de las alternativas. Sin embargo, la presencia de IRA (creatinina elevada), con volúmenes elevados de diuresis y sobre todo el sodio urinario mayor a 20 mEq/L hacen que sea seguro una NTA, probablemente producida por la gentamicina y por la hipovolemia. La A (GNA, asociada a endocarditis) tendría hipocomplementemia y hematuria dismórfica. La B (SHU) tendría oliguria, trombopenia y hemólisis. La C (prerrenal) tendría sodio urinario < 10 mEq/L. La D (nefritis intersticial) tendría exantema, fiebre, oliguria y eosinofilia.

Fuente: Nefrología, cuestionario 5.6, P7

10. ¿Qué examen es más adecuado para enfrentar a un paciente en el que se sospecha una insuficiencia renal de tipo post-renal?

a. Fracción excretada de sodio
b. Ecografía abdominal
c. Uretrocistografía retrógrada
d. Cistoscopía
e. PieloTAC

Respuesta correcta: b. Ecografía abdominal

Explicación: La ecografía abdominal es el examen de elección para evaluar la obstrucción de la vía urinaria (causa de la insuficiencia renal post-renal), ya que la confirma, localiza y, muchas veces, además, identifica la causa. - La FeNa (A) sirve para diferenciar la IRA prerrenal de la renal. - La UCG (C) sirve para el diagnóstico de reflujo vesicoureteral, la estenosis uretral y las lesiones uretrales. - La cistoscopía (D) sirve para el estudio de la hematuria (última línea), en especial para diagnosticar cáncer de vejiga y cistitis intersticial. - El pieloTAC (E) es el examen de elección para evaluar los cálculos urinarios.

Fuente: Nefrología, cuestionario 5.6, P10 · Urología, cuestionario 6.3, P12

11. Un paciente de 65 años sufre un infarto con supradesnivel del ST, extenso, evolucionando con insuficiencia cardíaca aguda. En sus exámenes de control destacan una creatininemia de 2,3 mg/dl, proteinuria negativa, Na plasmático: 144 mEq/l, K plasmático: 5,1 mEq/L, Na urinario: 5 mEq/l y K urinario: 20 mEq/L. El diagnóstico más probable es:

a. Insuficiencia renal prerrenal
b. Necrosis tubular aguda
c. Glomerulonefritis aguda
d. Embolia de colesterol
e. Infarto renal

Respuesta correcta: a. Insuficiencia renal prerrenal

Explicación: El antecedente de insuficiencia cardíaca ya orienta a causa prerrenal. Sin embargo, se confirma con el sodio urinario bajo (menor a 10 mEq/L). La B (NTA) tendría sodio urinario mayor a 20 mEq/L y cilindros céreos o granulosos. La C (GNA) tendría sodio urinario elevado y hematuria dismórfica. La D (embolia de colesterol) produce dolor lumbar, hipocomplementemia, leucocituria, hematuria y falla renal. Suele ser secundaria a una angiografía, en que se suelta un émbolo de colesterol, que llega a los riñones y extremidades inferiores (se asocia a púrpura de extremidades inferiores post angiografía). La E (infarto renal) tiene dolor lumbar súbito, asociado a hematuria y falla renal, con antecedente de fibrilación auricular u otra causa de embolias.

Fuente: Nefrología, cuestionario 5.7, P3

12. Un niño de 4 años presenta una diarrea acuosa, de 3 días. Evoluciona con oliguria. Al examen físico se aprecian las mucosas secas y los ojos hundidos, su frecuencia cardiaca está aumentada. En sus exámenes de sangre se aprecia elevación del BUN a 60 mg/dl y de la creatinina a 2,3 mg/dl. El diagnóstico más probable es:

a. Síndrome hemolótico urémico
b. Glomerulonefritis postinfecciosa
c. Insuficiencia renal prerrenal
d. Nefrosis lipoidea
e. Necrosis tubular aguda

Respuesta correcta: c. Insuficiencia renal prerrenal

Explicación: Tiene una IRA (creatinina elevada). El antecedente de diarrea es sugerente tanto de SHU, como de IRA prerrenal. Que tenga mucosas secas y ojos hundidos (signos de deshidratación), hace que sea prerrenal. También lo sugiere la relación BUN/creatinina mayor a 20 (60/2,3 = 26). - Si hubiese tenido edema e hipertensión (signos de sobrecarga de volumen) o indicios de plaquetopenia o hemólisis, el diagnóstico sería SHU. - La GNAPE es un síndrome nefrítico, con complemento bajo. - La NTA es una IRA renal, con BUN/creatinina menor a 20 y generalmente con volúmenes urinarios elevados en la fase poliúrica (al inicio puede estar oligúrica y, en este caso, es posible que haya una NTA, pero lo primero

sigue siendo manejarla como prerrenal, ya que es lo más probable por lejos). - La nefrosis lipoidea es un síndrome nefrótico puro.

Fuente: Nefrología, cuestionario 5.7, P8

13. Un paciente presenta un cuadro de oliguria y elevación de la creatinina, de dos días de evolución. En sus exámenes destaca sodio urinario de 6 mg/dl y sedimento de orina sin hematuria, ni leucocituria, que solo muestra escasos cilindros hialinos. El diagnóstico más probable es:

a. Necrosis tubular aguda
b. Nefritis intersticial
c. Insuficiencia renal aguda prerrenal
d. Síndrome hemolítico urémico
e. Glomerulonefritis rápidamente progresiva

Respuesta correcta: c. Insuficiencia renal aguda prerrenal

Explicación: Tiene una insuficiencia renal (elevación de la creatinina) aguda (menor a 3 meses), de tipo prerrenal, ya que el sodio urinario es menor a 10 mEq/L (sugiere FeNa menor a 1%). Los cilindros hialinos son hallazgos normales y se pueden ver en las IRA prerrenal. Es la causa más frecuente de IRA, seguido por la necrosis tubular aguda (NTA). Las A (NTA) tendría sodio urinario mayor a 20 mEq/L (sugiere FeNa mayor a 2%) y es frecuente que tenga cilindros granulosos o céreos o abundantes células epiteliales en el sedimento urinario. La B (NI) tendría eosinofilia en el hemograma, eosinófilos en orina, más una clínica de exantema y fiebre. La D (SHU) sería un niño (más frecuente prescolar o lactante) con insuficiencia renal aguda de tipo renal (sodio urinario mayor a 20 mEq/L), con anemia hemolítica, plaquetopenia y, frecuentemente, antecedente de diarrea. La E (GNRP) tendría hematuria dismórfica, e insuficiencia renal aguda de tipo renal (sodio urinario mayor a 20). Además, es frecuente que tengan un síndrome nefrítico completo y los síntomas propios de la patología de base (generalmente vasculitis de vaso pequeño, como la poliangeítis microscópica y la granulomatosis con poliangeítis, también conocida como granulomatosis de Wegener); aunque, también puede ser lupus y enfermedad por anticuerpos antimembrana basal e incluso, en casos raros, ser una GNRP postestreptocócica.

Fuente: Nefrología, cuestionario 5.8, P1

14. Un paciente de 45 años presenta una endocarditis por S. aureus, la que es tratada con cloxacilina y gentamicina endovenosas. Evoluciona con deterioro de la función renal, con aumento de la creatinina plasmática a 4,3 mg/dl. Su examen físico no aporta mayor información, por lo que se solicitan exámenes que muestran sedimento de orina con cilindros céreos y granulosos, bacterias escasa cantidad, proteínas urinarias: 1,9 g en 24 horas, sodio urinario: 35 mEq/L, diuresis: 4.600 ml en 24 horas, sodio plasmático: 130 mEq/L, potasio plasmático: 3,1 mEq/L. El diagnóstico más probable es:

a. Insuficiencia renal aguda prerrenal
b. Embolia renal séptica
c. Glomerulonefritis asociada a endocarditis
d. Necrosis tubular aguda
e. Trombosis de la vena renal

Respuesta correcta: d. Necrosis tubular aguda

Explicación: Es una NTA en fase poliúrica (4,6 litros diarios: pierde mucha agua y electrolitos). Además, el Na+ urinario mayor a 20 mEq/l es definitorio de una IRA renal y los cilindros granulosos y céreos son característicos de la NTA. - La A (IRA prerrenal) habría tenido Na+ urinario bajo (menor a 10 mEq/L) y diuresis escasa. - La B (embolia séptica) habría tenido clínica de un infarto renal: un cuadro de dolor

lumbar intenso, similar a un cólico renal, más hematuria (dismórfica), insuficiencia renal y leucocituria. - La C (GNA asociada a endocarditis) habría tenido hematuria dismórfica y complemento bajo. - La E (trombosis de la vena renal) es una complicación del síndrome nefrótico y cursa con dolor lumbar, hematuria e IRA.

Fuente: Nefrología, cuestionario 5.8, P1

15. Mujer de 56 años, ingresa por cuadro de hemorragia digestiva por várices esofágicas, en contexto de daño hepático crónico. Inicialmente presenta hipotensión y oliguria, que revierte luego de recibir fluidos, terlipresina y realizarse ligadura endoscópica de urgencia de las várices. En sus exámenes destaca Creatinina: 4,0 mgdl y BUN: 90 mg/dl. Se constata sodio urinario de 5 mEq/l y sodio plasmático de 130. La causa más probable de su alteración de la función renal es:

a. Síndrome hepatorrenal
b. Infarto renal
c. Nefritis intersticial
d. Necrosis tubular aguda
e. Hipovolemia con compromiso prerrenal

Respuesta correcta: e. Hipovolemia con compromiso prerrenal

Explicación: Tanto por el antecedente de hemorragia, como por el uso de terlipresina, lo más probable es que sea prerrenal. Sin embargo, los exámenes vuelven el diagnóstico mucho más probable, ya que hay una relación BUN/Creatinina mayor a 20 y el sodio urinario está bajo 10 mEq/L. El síndrome hepatorrenal también tiene estos exámenes, pero su diagnóstico depende de que no responda al manejo y que se descarten las demás causas.

Fuente: Nefrología, cuestionario 5.8, P3

16. Un paciente, portador de una insuficiencia cardíaca, presenta un edema pulmonar agudo, el que es manejado con furosemida endovenosa, con buena respuesta. Sin embargo, evoluciona con oliguria, constatándose una elevación de la creatinina de 1,0 a 2,1 mg/dl. La causa más probable de su insuficiencia renal es:

a. Prerrenal
b. Necrosis tubular aguda
c. Nefritis intersticial
d. Infarto renal
e. Pseudoinsuficiencia renal por diuréticos

Respuesta correcta: a. Prerrenal

Explicación: El solo hecho de tener insuficiencia cardíaca, ya aumenta el riesgo de que esté prerrenal, ya que el corazón no bombea bien la sangre a los riñones. Pero en este caso, lo importante es que el uso de furosemida, le hizo perder volemia y eso lo vuelve prerrenal. También se ha preguntado, en relación al uso de diuréticos en el síndrome nefrótico, ya que si bien disminuye el edema, tienen riesgo de volverlo prerrenal, al hipovelemizarlo. Algo a comentar es que generalmente la IRA prerrenal se trata volemizando al paciente con suero fisiológico u otro cristaloide, pero, hay que tener mucho cuidado en los casos en que es causada por insuficiencia cardíaca severa, ya que se puede generar un edema pulmonar, por lo que lo más importante será el tratamiento de la insuficiencia cardíaca, lo que indirectamente tratará también la insuficiencia renal. - La B (NTA) es una IRA de tipo renal, con cilindros céreos y granulosos en el sedimento y secundaria a isquemia renal o a uso de aminoglicósidos u otros nefrotóxicos. - La C (Nefritis intersticial) es una IRA renal, con eosinofilia y eosinófilos en orina, más un cuadro sistémico de fiebre, exantema,

asociado a uso de AINEs o Sd. Sjörgren. - La D (infarto renal) se presenta como un cuadro de dolor lumbar intenso, similar a un cólico renal, más hematuria (dismórfica), insuficiencia renal y leucocituria. - La E (pseudoisuficiencia renal) no existe.

Fuente: Nefrología, cuestionario 5.8, P4

17. ¿Cuál de las siguientes es una indicación de hemodiálisis de urgencia, en un paciente cursando una insuficiencia renal aguda?

a. Encefalopatía urémica
b. BUN mayor a 60 mg/dl
c. Creatinina mayor a 6 mg/dl
d. Hiperkalemia de 6 mEq/L
e. Calcemia de 6 mEq/L

Respuesta correcta: a. Encefalopatía urémica

Explicación: Las indicaciones de hemodiálisis de urgencia son dos: 1. Síndrome urémico (como en este caso, con encefalopatía urémica) y 2. Complicaciones graves que no responden a tratamiento médico (ej. hiperkalemia >6,5 que no responde a calcio y diuréticos; edema pulmonar que no responde a diurético; acidosis que no responde a bicarbonato: casi siempre responde la acidosis). Los niveles de creatinina per sé no son indicación de diálisis. Los niveles de BUN tampoco, pero en general sobre BUN de 100 mg/dl, suele haber un síndrome urémico, por lo que se considera que sobre 100 mg/dl es una indicación relativa, aunque la evidencia es clara en que solo está indicada en las 2 situaciones descritas inicialmente.

Fuente: Nefrología, cuestionario 5.8, P9

18. Un paciente cursando con un síndrome nefrótico, con marcado edema y albúmina de 1,9 g/dl, presenta creatinina basal de 1,0 mg/dl. Se inician diuréticos de asa por vía endovenosa, como tratamiento del edema, lográndose clara disminución del mismo, sin embargo evoluciona con oliguria y elevación de la creatinina a 2,8 mg/dl. El diagnóstico más probable es:

a. Nefritis por diuréticos
b. Estenosis de la arteria renal
c. Insuficiencia renal prerrenal
d. Necrosis tubular aguda
e. Glomerulonefritis mesangiocapilar

Respuesta correcta: c. Insuficiencia renal prerrenal

Explicación: El uso de diuréticos en el síndrome nefrótico, si bien disminuye el edema, tiene riesgo de volverlo prerrenal, al hipovelemizarlo. En particular, porque el edema no es por exceso de volumen, sino por una falta de proteínas, que reduce la presión oncótica capilar. - La A (Nefritis intersticial por diuréticos) es muy rara y cursa con IRA renal, con eosinofilia y eosinófilos en orina, más un cuadro sistémico de fiebre, exantema, (está más asociado a uso de AINEs, antibióticos o secundaria al Sd. de Sjörgren, pero sí se puede ver muy raramente en los diuréticos). - La B (estenosis arteria renal) es un cuadro de hipertensión de tipo renovascular (con presiones elevadas, refractarias, empeoramiento de la función renal con IECAs o ARA2 y presencia de hipokalemia). - La D (NTA) es una IRA de tipo renal, con cilindros céreos y granulosos en el sedimento y secundaria a isquemia renal o a uso de aminoglicósidos u otros nefrotóxicos. - La E (GNMC) tendría hematuria, hipocomplementemia y proteinuria (síndrome nefrótico impuro o nefrítico).

Fuente: Nefrología, cuestionario 5.8, P14

19. Un paciente de 60 años, diagnosticado de artrosis, inicia tratamiento con ibuprofeno 400 mg cada 8 horas. Dos semanas después presenta fiebre, oliguria y aparición de un exantema cutáneo. En sus exámenes destaca eosinofilia y creatinina de 4,2 mg/dl. El diagnóstico más probable es:

a. Glomerulonefritis mesangiocapilar
b. Glomerulonefritis lúpica
c. Infarto renal
d. Necrosis tubular
e. Nefritis intersticial

Respuesta correcta: e. Nefritis intersticial

Explicación: Es una nefritis intersticial clásica (uso prolongado de AINEs y/o antibióticos, con insuficiencia renal, fiebre, exantema y eosinofilia). En este caso, además, existe un síndrome de DRESS (reacción cutánea a drogas con eosinofilia y síntomas sistémicos), que es de las reacciones a fármacos más graves. El diagnóstico confirmatorio se hace con la biopsia renal, que muestra inflamación del intersticio renal. El tratamiento incluye suspender los fármacos, dar corticoides y dar soporte (ej. diálisis si hay falla renal severa). - La A (GNMC) tendría hematuria, hipocomplementemia y proteinuria (síndrome nefrótico impuro o nefrítico). - La B (Lupus) también tendría hematuria, hipocomplementemia y proteinuria y sería en una mujer más joven. - La C (infarto renal) se presenta como un cuadro de dolor lumbar intenso, similar a un cólico renal, más hematuria (dismórfica), insuficiencia renal y leucocituria, habitualmente en presencia de alguna causa de isquemia, como una embolia por fibrilación auricular o embolia secundaria a una arteriografía, etc. - La D (NTA) es una IRA de tipo renal, con cilindros céreos y granulosos en el sedimento y secundaria a isquemia renal o a uso de aminoglicósidos u otros nefrotóxicos.

Fuente: Nefrología, cuestionario 5.8, P18

Insuficiencia renal crónica y diálisis (15)

20. Un paciente de 60 años, insuficiente renal crónico, tiene un clearence de creatinina de 30 ml/min. ¿Cuál de las siguientes medidas es más adecuada para evitar el desarrollo de acidosis en este paciente?

a. Administrar carbonato de calcio
b. Administrar bicarbonato de sodio
c. Iniciar un diurético tiazídico
d. Iniciar un diurético de asa
e. Aumentar la ingesta de agua

Respuesta correcta: b. Administrar bicarbonato de sodio

Explicación: Los pacientes con IRC reciben NaHCO3 para evitar la acidosis. - El carbonato de calcio sirve para el hiperparatiroidismo secundario y la osteodistrofia renal. - Los diuréticos no son parte estricto del tratamiento de la IRC, a menos que exista otra patología que los requiera (ej. ICC o HTA: recordar que los diuréticos son la medida farmacológica más eficaz para la HTA por hipervolemia de la IRC) o que haya mucho edema. - Finalmente, la ingesta de agua se debe moderar en el paciente con IRC, para evitar la sobrecarga de volumen y la hiponatremia.

Fuente: Nefrología, cuestionario 5.3, P9

21. Un paciente de 59 años, diagnosticado de insuficiencia renal crónica, secundario a nefropatía hipertensiva, presenta anemia con hematocrito de 27% y hemoglobina de 9 g/dl. Se solicita ferritina plasmática, la que resulta 330 ng/ml y saturación de transferrina, que resulta 50%. La conducta más adecuada es:

a. Iniciar hierro endovenoso
b. Iniciar hierro oral
c. Solicitar niveles plasmáticos de eritropoyetina
d. Iniciar eritropoyetina subcutánea
e. Observar evolución

Respuesta correcta: d. Iniciar eritropoyetina subcutánea

Explicación: Tiene una anemia asociada a IRC. Hay que cumplir dos objetivos: Primero: ajustar el perfil de hierro (Ferritina mayor a 400 o mayor a 100, con saturación de transferrina mayor a 20%), lo que se logra con hierro endovenoso en pacientes con IRC en diálisis o con anemia o ferropenia severas. Segundo: lograr un hematocrito sobre 30% o hemoglobina sobre 10 g/dl, con eritropoyetina subcutánea. En este caso, ya cumple con el objetivo del hierro, por lo que no es necesario indicarlo. Sin embargo, no cumple con el objetivo del hematocrito, por lo que está indicada la EPO (eritropoyetina, ya sea como epoetina alfa o darbepoetina). Como detalle, una ferritina sobre 500 o una saturación de transferrina sobre 30% son, individualmente, muy sugerentes de estar con los depósitos de hierro repletos.

Fuente: Nefrología, cuestionario 5.3, P18

22. Un paciente, diagnosticado de IRC, secundaria a diabetes mellitus, está en hemodiálisis hace 2 años. Presenta anemia con hematocrito de 28%, con hemoglobina de 9,2 g/dl y astenia. Actualmente no recibe tratamiento para la anemia. La conducta más adecuada es:

a. Observar evolución
b. Solicitar perfil de fierro y decidir manejo, según resultado
c. Iniciar eritropoyetina subcutánea
d. Iniciar sulfato ferroso oral
e. Realizar transfusión de glóbulos rojos

Respuesta correcta: b. Solicitar perfil de fierro y decidir manejo, según resultado

Explicación: Tiene una anemia asociada a IRC. Hay que cumplir dos objetivos: 1. Ajustar el perfil de hierro, lo que se logra con hierro endovenoso en los pacientes en diálisis; 2. Lograr un hematocrito sobre 30% o hemoglobina sobre 10 g/dl (máximo llegar a 11,5 g/dl), con eritropoyetina subcutánea o un análogo. En este caso, no cumple el objetivo de la hemoglobina y no sabemos si cumple o no con el objetivo del perfil de hierro. Como lo primero a corregir debe ser el hierro, en primer lugar, debemos solicitar un perfil de hierro, para poder decidir. Si está alterado, se indicará el hierro endovenoso. Si está normal, se deberá iniciar la EPO subcutánea.

Fuente: Nefrología, cuestionario 5.4, P11

23. Un paciente con insuficiencia renal por hipertensión arterial presenta elevación de la PTH plasmática, con calcio de 8,5 mg/dl y fósforo de 5,6 mg/dl. No presenta otros síntomas y su clearence de creatinina es de 50 ml/min. La conducta más adecuada es:

a. Iniciar bicarbonato de sodio
b. Iniciar carbonato de calcio y vitamina D
c. Iniciar furosemida oral

d. Iniciar hidroclorotiazida oral
e. Realizar paratiroidectomía

Respuesta correcta: b. Iniciar carbonato de calcio y vitamina D

Explicación: El tratamiento del hiperparatiroidismo secundario a la IRC es una dieta baja en fósforo, más lo siguiente: 1. Suplementar vitamina D si está baja (medirla antes). 2. Dar quelantes de fósforo, si está mayor a 5,5 mg/dl. Generalmente se usa el carbonato de calcio como quelante, a menos que el producto calcio-fósforo sea mayor a 55, en que se usan otros quelantes sintéticos. En este caso el producto calcio-fósforo es 8,5 x 5,6 = 47,6, por lo que se puede usar el carbonato de calcio. 3. Dar más calcio, si la calcemia es menor a 8,5 - 7,5 mg/dl. 4. Si la PTH sigue elevada, a pesar de todo lo anterior, dar más vitamina D y, eventualmente, calcimiméticos. - La paratiroidectomía es el tratamiento del hiperparatiroidismo primario y, en este caso, es un hiperparatiroidismo secundario.

Fuente: Nefrología, cuestionario 5.4, P13

24. La osteodistrofia renal se caracteriza por:

a. Elevación de la paratohormona
b. Elevación de la calcitonina
c. Elevación de la calcemia
d. Disminución de la fosfemia
e. Disminución del producto calcio-fósforo

Respuesta correcta: a. Elevación de la paratohormona

Explicación: La IRC produce retención de fósforo (eleva la fosfemia), lo que quela al calcio (disminuye la calcemia) y ambas cosas estimulan la PTH (se eleva la paratohormona). En paralelo disminuye la producción de vitamina D (que requiere hidroxilación a nivel renal), lo que también eleva la PTH y baja la calcemia. La disminución de la calcemia disminuye la calcitonina, la que habitualmente no se mide. El producto calcio fósforo (calcio x fósforo) se eleva (normal es <40) y si está sobre 60, tiene riesgo de calcifilaxis (calcificación de los órganos).

Fuente: Nefrología, cuestionario 5.5, P4

25. Para evitar la progresión de la insuficiencia renal crónica se debe realizar todo lo siguiente, EXCEPTO:

a. Mantener presiones arteriales menores a 130/80 mmHg
b. Evitar el consumo de AINES y aminoglicósidos
c. Indicar diuréticos de asa para mantener un volumen urinario alto
d. Disminuir la proteinuria con IECAs
e. Mantener un adecuado control metabólico, con hemoglobina glicosilada menor a 7,0

Respuesta correcta: c. Indicar diuréticos de asa para mantener un volumen urinario alto

Explicación: El tratamiento de los factores de riesgo es muy importante, como la diabetes (opción E) y la HTA (opción A; recordando que en la IRC, el objetivo es <130/80 mmHg). También se deben evitar los nefrotóxicos (opción B). Además, sirven los IECAs (opción D), en caso de que haya proteinuria y las estatinas, en caso de que haya dislipidemia. En cambio, los diuréticos, si bien aumentan la diuresis, no tienen un real efecto sobre la función renal, e incluso tienen el riesgo de volverlo prerrenal; la furosemida sí es útil para el manejo de la HTA y edema asociados a IRC, sin embargo, no se busca diuresis elevadas, ya que solo sería un beneficio cosméticos (elevar el volumen urinario), pero sin ningún impacto en la filtración glomerular (o función renal).

Fuente: Nefrología, cuestionario 5.5, P8

26. Un paciente de 60 años, diabético, portador de una insuficiencia renal crónica terminal, en hemodiálisis hace 3 años, presenta anemia en el hemograma, con hematocrito de 25% y hemoglobina de 8,2 g/dl. La conducta más adecuada es:

a. Observar evolución
b. Solicitar perfil de hierro y decidir conducta según resultados
c. Iniciar eritropoyetina subcutánea
d. Iniciar eritropoyetina subcutánea y hierro oral
e. Iniciar eritropoyetina subcutánea y hierro endovenoso

Respuesta correcta: b. Solicitar perfil de hierro y decidir conducta según resultados

Explicación: Tiene una anemia asociada a IRC. Hay que cumplir dos objetivos: Primero: ajustar el perfil de hierro (Ferritina mayor a 400-500; o mayor a 100, con saturación de transferrina mayor a 20%), lo que se logra con hierro endovenoso en los pacientes en diálisis o con anemias o ferropenia severa. Segundo: lograr un hematocrito sobre 30% o hemoglobina sobre 10 g/dl, con eritropoyetina subcutánea o análogos. En este caso, no cumple el objetivo de la hemoglobina y no sabemos si cumple o no con el objetivo del perfil de hierro. Como lo primero a corregir debe ser el hierro, en primer lugar, debemos solicitar un perfil de hierro, para poder decidir. Si está alterado, se indicará el hierro endovenoso. Si está normal, se deberá iniciar la EPO subcutánea.

Fuente: Nefrología, cuestionario 5.6, P9

27. Un paciente de 58 años, diabético, con insuficiencia renal crónica, en hemodiálisis, hace 2 años, se realiza un hemograma, que muestra anemia con hematocrito: 35%, Hb: 11,8 g/dl y VCM: 90 fl, con normalidad de la serie blanca y plaquetas. Se solicita un perfil de fierro, que muestra ferritina 430 ng/ml, (VN: 15-300 ng/ml), saturación de transferrina: 30%. La conducta más adecuada para el tratamiento de su anemia es:

a. Observar evolución
b. Iniciar fierro oral
c. Iniciar fierro endovenoso
d. Iniciar eritropoyetina subcutánea
e. Realizar transfusión de glóbulos rojos

Respuesta correcta: a. Observar evolución

Explicación: Tiene una anemia asociada a IRC. Hay que cumplir dos objetivos: - Primero: ajustar el perfil de hierro (Ferritina mayor a 400 o mayor a 100 más saturación de transferrina mayor a 20%; algunos también aceptan la saturación de transferrina mayor a 30% por sí sola), lo que se logra con hierro endovenoso en pacientes en diálisis. - Segundo: lograr un hematocrito sobre 30% o hemoglobina sobre 10 g/dl, con eritropoyetina subcutánea o sus análogos (epoietina y darbepoietina). * En este caso, ya cumple con el objetivo del hierro, por lo que no es necesario indicarlo. Además, también cumple con el objetivo del hematocrito, por lo que tampoco está indicada la EPO.

Fuente: Nefrología, cuestionario 5.7, P6

28. Un paciente de 60 años, diagnosticado de insuficiencia renal crónica terminal, en hemodiálisis trisemanal, en buen estado, se realiza exámenes de control, que muestran ferritina de 200 ug/L, transferrina: 40% de saturación y un hemograma con Hb: 11 g/dl, Hematocrito: 33% y VCM: 90 fl, con normalidad de las plaquetas y glóbulos blancos. La conducta más adecuada es:

a. Observar evolución y mantener indicaciones

b. Iniciar hierro endovenoso
c. Solicitar biopsia de médula ósea
d. Iniciar eritropoyetina
e. Indicar vitaminas del complejo B

Respuesta correcta: a. Observar evolución y mantener indicaciones

Explicación: Tiene una anemia asociada a IRC. Hay que cumplir dos objetivos: Primero: ajustar el perfil de hierro (Ferritina mayor a 400 o mayor a 100, con saturación de transferrina mayor a 20%), lo que se logra con hierro endovenoso. Segundo: lograr un hematocrito sobre 30% o hemoglobina sobre 10 g/dl, con eritropoyetina subcutánea. En este caso, ya cumple con el objetivo del hierro, por lo que no es necesario indicarlo. Además, también cumple con el objetivo del hematocrito, por lo que tampoco está indicada la EPO. - Se prefiere dar hierro endovenoso en los pacientes con IRC y ferropenia, ya que el hierro por vía oral suele tener malos resultados. Sin embargo, es aceptable darlo oral en pacientes que no están en diálisis, que tienen ferropenia no severa (saturación transferrina >12%) y anemia no severa. - Algunas guías internacionales establecen como objetivos del hierro cualquiera de los siguientes tres: 1. Ferritina >500; 2. Saturación transferrina > 30% o 3. Ferritina >100 más saturación transferrina > 20%. - La eritropoyetina u otros estimuladores de la eritropoyesis se ajustan para lograr hemoglobina entre 10 y 11,5 g/dl, ya que valores mayores se asocian a mayor riesgo cardiovascular.

Fuente: Nefrología, cuestionario 5.8, P2

29. Un paciente de 65 años, diabético e hipertenso es diagnosticado de insuficiencia renal crónica, con un clearence de creatinina de 50 ml/min. Además presenta proteinuria positiva, de 400 mg/día. ¿Cuál de las siguientes medidas es MENOS aconsejable para el tratamiento de este paciente?

a. Iniciar un IECA
b. Iniciar una estatina
c. Indicar furosemida en dosis altas
d. Evitar aminoglicósidos y AINEs
e. Iniciar insulina

Respuesta correcta: c. Indicar furosemida en dosis altas

Explicación: Tiene una IRC en etapa III (clearence 30 a 60 ml/min). La proteinuria está apenas sobre el valor normal (hasta 300 mg/día), aunque vale la pena medir albuminuria, ya que la albuminuria normal es menor a 30 mg/día y valores más elevados sugieren una nefropatía (de todos modos, en este caso, ya hay caída del clearence). - Los IECA son útiles porque disminuyen la proteinuria, lo que también disminuye la progresión de la IRC. - La estatina también es útil para disminuir la progresión, si es que hay dislipidemia asociada. - Se deben evitar los nefrotóxicos, como los AG y los AINEs. - Además, la IRC es una de las indicaciones del uso de insulina en los pacientes diabéticos, ya que están contraindicados los HGO tradicionales (sí se aceptan varios de los nuevos y más modernos). - En cambio, los diuréticos, como la furosemida, no evitan la progresión, sino que solo aumentan cosméticamente la diuresis, pero sin aumentar la filtración glomerular. Es más, tienen el riesgo de hipovolemizar al paciente y volverlo prerrenal, agravando el grado de insuficiencia renal. Eso sí, tienen un claro rol en la IRC con edema más hipertensión o hiperkalemia, pero no se usan en dosis altas, salvo casos excepcionales (ej. edema pulmonar agudo por hipervolemia scuendaria a la falla renal).

Fuente: Nefrología, cuestionario 5.8, P4

30. Un paciente de 65 años, en hemodiálisis hace 4 años, presenta anemia con hematocrito de 25% y hemoglobina de 8,1 gramos/dl. Se solicita un perfil de hierro que muestra ferritina: 50 ug/l y saturación de la transferrina de 10%. La conducta más adecuada es:

a. Observar evolución
b. Transfundir glóbulos rojos
c. Iniciar eritropoyetina subcutánea
d. Iniciar hierro oral
e. Iniciar hierro endovenoso

Respuesta correcta: e. Iniciar hierro endovenoso

Explicación: Tiene una anemia asociada a IRC. Hay que cumplir dos objetivos: 1. Ajustar el perfil de hierro y 2. lograr un hematocrito sobre 30% o hemoglobina sobre 10 g/dl (ideal 10-11,5 g/dl), con eritropoyetina subcutánea. El objetivo del perfil de hierro en adultos con IRC varía según la fuente: - Guía Minsal 2005: Ferritina mayor a 100 más saturación de transferrina mayor a 20% o ferritina mayor a 400. - Otras guías internacionales: Ferritina mayor a 100 más saturación de transferrina mayor a 30% o ferritina mayor a 500 o saturación mayor a 30%. La vía de administración del hierro en la IRC suele ser endovenosa (varias marcas y presentaciones, todas igual de efectivas), ya que no andan bien con la vía oral. La excepción serían pacientes sin diálisis, sin anemia severa (entendida como Hb<7) ni ferropenia severa (entendida como saturación de transferrina >12%), que tengan buena adherencia y que respondan rápido al hierro oral (en ese caso se puede tratar con sulfato ferroso 325 mg, equivalentes a 200 mg de hierro elemental c/8 horas u otro hierro oral más caro). En este caso no se cumple ninguno de los dos objetivos (hierro ni hemoglobina), por lo que se debe ir en orden, arreglando el perfil de hierro en primer lugar, lo que se hace con hierro por vía endovenosa, ya que el la IRC, el hierro oral tiende a ser poco efectivo. Solo si se corrige el hierro y sigue la hemoglobina bajo 10 g/dl, se procede a indicar eritropoyetina u otros estimulador de la eritropoyesis.

Fuente: Nefrología, cuestionario 5.8, P8

31. La insuficiencia renal crónica se caracteriza por todo lo siguiente, EXCEPTO:

a. Elevación de la calcemia
b. Elevación de la fosfemia
c. Elevación de la paratohormona plasmática
d. Elevación del producto calcio-fósforo
e. Disminución de la vitamina D

Respuesta correcta: a. Elevación de la calcemia

Explicación: Fisiopatológicamente, lo que sucede es que se retiene fósforo, lo que aumenta la fosfemia. El fósforo quela al calcio, por lo que baja la calcemia. Tanto el calcio a la baja, como el fósforo en alza, estimulan a la PTH, quien trata de mantener los niveles de ambos dentro de los normal (la PTH aumenta el calcio y reduce el fósforo). Por eso el tratamiento consiste en indicar calcio oral, para quelar el fósforo y aumentar el calcio. El producto calcio fósforo es la multiplicación entre el calcio y el fósforo y lo normal es que sea menor a 40, pero con la IRC va elevándose y si pasa el umbral de 60, aumenta el riesgo de calcificaciones metastásicas (calcifilaxis), lo que hace que cuando está sobre 55, no se puede indicar el carbonato de calcio oral, sino otros quelantes de fósforo, como el Sevelamer.

Fuente: Nefrología, cuestionario 5.8, P10

32. Un paciente es diagnosticado de insuficiencia renal crónica, en etapa III. ¿Qué fármaco debe evitar, de entre los de las siguientes alternativas?

a. Diclofenaco
b. Amoxicilina
c. Atorvastatina
d. Amlodipino
e. Levotiroxina

Respuesta correcta: a. Diclofenaco

Explicación: Por regla general, en los pacientes con IRC se deben evitar los nefrotóxicos (ej. AINES y aminoglicósidos) y además se deben ajustar las dosis de los medicamentos. El diclofenaco es un AINE, y por tanto nefrotóxico. No es necesario saber todos los nefrotóxicos, pero sí los AINEs. La atorvastatina no solo que no está contraindicada, sino que puede estar indicada, en caso de dislipidemia, ya que disminuye la progresión de la insuficiencia renal y por otro lado, la IRC es un factor de riesgo cardiovascular.

Fuente: Nefrología, cuestionario 5.8, P13

33. ¿Qué alteración, de entre las enumeradas, aparece más tardíamente en un paciente con insuficiencia renal crónica?

a. Anemia
b. Elevación de la paratohormona
c. Acidosis metabólica
d. Elevación del nitrógeno ureico urinario
e. Disminución de la calcemia

Respuesta correcta: c. Acidosis metabólica

Explicación: El BUN se eleva desde la etapa II (clearence <90 ml/min). La anemia y elevación de la PTH también pueden ocurrir desde la etapa II. La caída del calcio empieza desde la etapa III (<60 ml/min) o incluso desde la II. La acidosis y la hiperkalemia ocurren desde la etapa IV (<30 ml/min). El síndrome urémico (ej. Pericarditis, encefalopatía, hipo, etc) empieza en la etapa V (<15ml/min).

Fuente: Nefrología, cuestionario 5.8, P15

34. El mejor examen para diferenciar una insuficiencia renal aguda, de una insuficiencia renal crónica es:

a. Clearence de creatinina
b. Relación BUN/creatinina plasmática
c. Fracción excretada de sodio
d. Ecografía renal
e. Paratohormona plasmática

Respuesta correcta: d. Ecografía renal

Explicación: La ecografía renal es el examen de elección. Si los riñones se ven pequeños, atróficos e hiperecogénicos, probablemente será una IRC. Si están grandes y normales, probablemente será una IRA. Sin embargo, hay algunas IRC con riñones grandes (Diabetes, mieloma, amiloidosis, VHC, VHB, VIH). Eso sí, la única manera de hacer realmente la diferencia es con el tiempo de evolución, ya que, si persiste luego de 3 meses, a pesar del manejo de las posibles causas, con certeza es una IRC. En cambio, si revierte, es una IRA. Si revierte parcialmente, pues hay un componente agudo que mejoró, sobre el crónico, que permanece.

Fuente: Nefrología, cuestionario 5.8, P19

Síndrome nefrótico y glomerulopatías (12)

35. Es una causa frecuente de síndrome nefrótico, en el paciente VIH:

a. Nefropatía por IgA
b. Glomerulonefritis crescéntica
c. Glomeruloesclerosis focal y segmentaria
d. Glomeropatía por cambios mínimos
e. Glomerulonefritis difusa aguda

Respuesta correcta: c. Glomeruloesclerosis focal y segmentaria

Explicación: La causa más frecuente de síndrome nefrótico en el paciente VIH es la GEFS (seguido de la glomerulopatía membranosa). También la GEFS es la causa más frecuente de síndrome nefrótico en los adolescentes. El diagnóstico se hace con la biopsia renal. El tratamiento incluye el manejo general del síndrome nefrótico (ej. IECA para disminuir la proteinuria) más el tratamiento de la causa de base. - La A (nefropatía por IgA) rara vez produce síndrome nefrótico y suele producir hematuria sola o síndrome nefrítico. - La B (GN crescéntica) es el equivalente histológico de la GNRP, es decir, es causa de IRA grave, con hematuria dismórfica. No tiene síndrome nefrótico. - La D (cambios mínimos) es causa de síndrome nefrótico puro, pero en niños. - La E (glomerulonefritis difusa aguda) es la histología más frecuente de la GNAPE, la que cursa con síndrome nefrítico y no nefrótico.

Fuente: Nefrología, cuestionario 5.3, P6

36. Un niño de 8 años presenta un cuadro de edema generalizado y orinas espumosas. Al examen físico presenta signos vitales normales y se constata edema de extremidades inferiores y de la cara. En sus exámenes presenta creatinina: 0,6 mg/dl, K+: 4,0 mEq/L, Na+: 140 mEq/L, colesterol: 250 mg/dl, albúmina: 2,5 g/dl, proteinuria 3,2 g/día, de tipo selectiva y complemento: normal. El diagnóstico más probable es:

a. Glomerulopatía membranosa
b. Glomerulonefritis mesangiocapilar
c. Nefrosis lipoidea
d. Glomerulonefritis postestreptocócica
e. Síndrome hemolítico urémico

Respuesta correcta: c. Nefrosis lipoidea

Explicación: Es un niño con un síndrome nefrótico puro: tiene 1. la proteinuria en rango nefrótico (mayor a 40 mg/m2/hora en niños, ya que es mayor a 3 g/día, lo que es nefrótico incluso en un adulto), 2. El edema, 3. La dislipidemia y 4. La hipoalbuminemia (albúmina menor a 3,5 g/dl). Por tanto lo más probable es una nefrosis lipoidea, también llamada glomerulopatía por cambios mínimos. - La A (GP membranosa) es causa de Sd. nefrótico puro en adultos (se asocia a lupus, uso de drogas). - La B (GNMC) es causa de Sd. nefrótico impuro. Además, tiene el complemento bajo. - La D (GNAPE) es causa de Sd. nefrítico con complemento bajo. - La E (SHU) es causa de insuficiencia renal grave o no de síndrome nefrótico. Cursa además con hemólisis y trombopenia.

Fuente: Nefrología, cuestionario 5.3, P20

37. Un paciente de 30 años consulta por un cuadro de anasarca. Al examen físico presenta hipertensión arterial y edema facial, escrotal y de extremidades. En sus exámenes destaca una proteinuria de 8,2

gramos al día, índice proteinuria/creatininuria: 7,0, sedimento de orina con microhematuria dismórfica de 20 GR por campo, albuminemia: 2,5 g/dl, creatinina: 2,0 mg/dl, colesterol total: 250 mg/dl. El diagnóstico más probable es:

a. Síndrome nefrítico
b. Síndrome nefrótico
c. Síndrome hemolítico urémico
d. Necrosis tubular aguda
e. Nefritis intersticial

Respuesta correcta: b. Síndrome nefrótico

Explicación: Tiene un síndrome nefrótico impuro. Es nefrótico, porque tiene proteinuria en rango nefrótico (mayor a 3 g/día), más edema, hipoalbuminemia y dislipidemia. Además, es impuro, porque tiene microhematuria dismórfica. Le falta la HTA para poder ser nefrítico y, aunque la tuviera, seguiría primando el diagnóstico de síndrome nefrótico (nefrítico + nefrótico = nefrótico... impuro). En este caso también hay una insuficiencia renal (con creatinina de 2 mg/dl), causada por la glomerulonefritis que tiene de base (hematuria dismórfica), aunque también puede estar agravada por la proteinuria (a largo plazo, produce daño renal). - El SHU es una insuficiencia renal aguda grave de los niños. - La NTA es una IRA renal, sin proteinuria en rango nefrótico. - La nefritis intersticial tiene exantema, fiebre, IRA y eosinofilia más eosinófilos en orina.

Fuente: Nefrología, cuestionario 5.4, P5

38. La glomerulopatía más frecuente causada por fármacos es:

a. Glomeruloesclerosis focal y segmentaria
b. Glomerulonefritis crescéntica
c. Amiloidosis renal
d. Glomerulopatía membranosa
e. Glomeruloesclerosis difusa

Respuesta correcta: d. Glomerulopatía membranosa

Explicación: La GP membranosa se por causa autoinmune primaria, pero también por reacción inmune secundaria a fármacos, infecciones o cáncer. Es la glomerulopatía asociada a fármacos más frecuente y se suele presentar como un síndrome nefrótico puro. Su tratamiento es el manejo general del síndrome nefrótico (ej. tratar la causa, disminuir la proteinuria con IECAs y manejar la falla renal crónica y sus complicaciones). - La A (GEFS) es clásica de adolescentes y pacientes VIH, aunque también puede ser por fármacos. - La B (GN crescéntica) es clásica de las vasculitis y otras causas de GNRP. - La C (amiloidosis) se ve en el riñón de mieloma y otras causas. El riñón de mieloma es un tipo de amiloidosis renal, con depósito de cadenas livianas, que forman cilindros en el nefrón distal. Se diferencia de la amiloidosis, por amiloide A, que se asocia a artritis reumatoide, pelviesponidiloartropatías y enfermedades inflamatorias intestinales. El diagnóstico se hace con la biopsia renal, aunque si hay una alta sospecha, se puede hacer biopsia de grasa abdominal, que muestra la amiloidosis y tiene mucho menos riesgo que la biopsia renal. Se trata con el manejo de la causa, ya que no hay un tratamiento específico. - La E (GE difusa) es clásica de la nefropatía diabética y se traduce en falla renal, con proteinuria generalmente no nefrótica.

Fuente: Nefrología, cuestionario 5.4, P12

39. Un niño de 6 años presenta aumento de volumen facial y orinas espumosas. Al examen físico está normotenso, con FC normal y sin otras alteraciones, excepto edema blando de cara y extremidades inferiores. En sus exámenes destaca proteinuria de 24 horas de 100 mg/m2/hora e hipoalmbuminemia. El

sedimento de orina muestra gotas de grasa, sin hematuria. La creatinina plasmática es 0,5 mg/dl y los electrolitos plasmáticos son normales. Presenta ANA(-), ANCA(-) y complemento normal. La conducta más adecuada es:

a. Iniciar prednisona oral
b. Solicitar biopsia renal
c. Iniciar furosemida en dosis altas
d. Administrar albúmina endovenosa
e. Indicar dieta hiperproteica y IECAs

Respuesta correcta: a. Iniciar prednisona oral

Explicación: Tiene un síndrome nefrótico puro (proteinuria mayor a 40 mg/m2/h, hipoalbuminemia, lipiduria y edema), lo que en un niño es muy sugerente de una nefropatía a cambios mínimos. Esta no se biopsia, sino que se trata directamente con corticoides orales en altas dosis. Si hubiese sido impuro (ej. HTA, hematuria o elevación de la creatinina), se habría tenido que biopsiar. - La furosemida se puede usar para disminuir el edema, pero tiene el riesgo de generar IRA prerrenal. - La albúmina EV solo se usa en casos de anasarca refractaria a los diuréticos, pero su utilidad es transitoria y limitada, por lo que lo más importante es tratar la causa y no reponer la albúmina. - Los IECAs sí sirven para disminuir la proteinuria, pero la dieta que se indica es normoproteica, ya que la hiperproteica aumenta la proteinuria y por tanto, el daño renal. * La medida más importante son los corticoides, ya que son los que permiten la resolución de la causa de base. Por regla general se indica prednisona 60 mg/m2 al día, por 6 semanas y, luego, 40 mg/m2 por 4 semanas más. Si responde antes, se puede adelantar el tratamiento (ej. 60 mg/m2 hasta que normalice la proteinuria y mantenerlo por un mes más, pasando luego a otro mes de 40 mg/m2 al día).

Fuente: Nefrología, cuestionario 5.4, P18

40. Un niño de 6 años presenta un síndrome nefrótico, con edema generalizado, proteinuria de 24 horas de 2 gramos por metro cuadrado de superficie corporal, albúmina de 2,8 g/dl, creatininemia de 0,8 mg/dl, sedimento de orina normal y complemento normal. La conducta más adecuada es:

a. Solicitar biopsia renal
b. Indicar dieta hipoproteica
c. Indicar IECAs y furosemida
d. Indicar prednisona
e. Solicitar anticuerpos anti DNA y anti Sm

Respuesta correcta: d. Indicar prednisona

Explicación: Tiene un síndrome nefrótico puro (proteinuria mayor a 40 mg/m2/h, lo que equivale a ser mayor a 1 g/m2/día; hipoalbuminemia y edema), lo que en un niño es muy sugerente de una nefropatía a cambios mínimos. Esta no se biopsia, sino que se trata directamente con corticoides orales en altas dosis. Si hubiese sido impuro (ej. HTA, hematuria o elevación de la creatinina), se habría tenido que biopsiar. La furosemida se puede usar para disminuir el edema, pero tiene el riesgo de generar IRA prerrenal. Los IECAs sí sirven para disminuir la proteinuria, pero lo más importante es tratar la causa, en este caso, con los corticoides. La dieta que se indica es normoproteica, ya que la hipoproteica aumenta la desnutrición proteica y la hiperproteica aumenta la proteinuria y por tanto, el daño renal. Sí se pueden pedir los anticuerpos anti-DNA y anti-Sm, pero en general solo se piden si los ANA están positivos o si hay un cuadro que sugiera lupus, ya que ambos son específicos de dicha enfermedad.

Fuente: Nefrología, cuestionario 5.5, P6

41. Un niño de 6 años consulta por aumento de volumen escrotal de algunos días de evolución. Al examinarlo bien usted nota que presenta edema escrotal, facial y de extremidades, sin otras alteraciones, por lo que decide solicitar exámenes de función renal que muestran: sedimento de orina normal, creatininemia de 0,6 mg/dl, BUN de 12 mg/dl, índice proteinuria / creatininuria de 4,1. El diagnóstico de sospecha es:

a. Glomerulopatía membranosa
b. Enfermedad por cambios mínimos
c. Enfermedad de Berger
d. Glomerulonefritis postestreptocócica
e. Glomerulonefritis mesangiocapilar

Respuesta correcta: b. Enfermedad por cambios mínimos

Explicación: Tiene un síndrome nefrótico puro en un niño, por lo que lo más probable es una nefrosis lipoidea, también llamada nefermedad por cambios mínimos. Tiene proteinuria en rango nefrótico (IP/C mayor a 3) y edema, aunque falta describir la albuminemia y los niveles de los lípidos. No tiene HTA, hematuria, ni IRA, por lo que es puro. - La A (membranosa) afecta a adultos y sí produce un síndrome nefrótico puro. - La C (Berger) es una glomerulonefritis, así que cursa con hematuria dismórfica y, a veces, Sd. nefrítico. Muy rara vez, nefrótico impuro. - La D (GNAPE) suele ser un síndrome nefrítico con hipocomplementemia. La E (GNMC) suele ser un síndrome nefrítico o síndrome nefrótico impuro, con hipocomplementemia.

Fuente: Nefrología, cuestionario 5.6, P1

42. Un paciente de 65 años consulta por edema marcado de extremidades inferiores. Al examen físico presenta signo de la fóvea, con PA: 120/80 y FC: 76x'. En sus exámenes destaca proteinuria de 10,2 gramos en 24 horas, con disminución de la albúmina plasmática. En su perfil lipídico se aprecia hipercolesterolemia, hipertrigliceridemia y hemoglobina glicosilada de 7%. Su creatinina es 0,7 mg/dl y sus niveles de complemento son normales. El diagnóstico más probable es:

a. Nefropatía diabética inicial
b. Nefropatía diabética establecida
c. Glomerulopatía membranosa
d. Glomeruloesclerosis focal y segmentaria
e. Nefrosis lipoidea

Respuesta correcta: c. Glomerulopatía membranosa

Explicación: Tiene un síndrome nefrótico puro (proteinuria mayor a 3 g/día, edema, hipoalbuminemia y dislipidemia; sin HTA ni hematuria), lo que, en adultos, es causado más frecuentemente por la GP membranosa. En este caso, por tener una hemoglobina glicosilada mayor a 6,5%, tiene el diagnóstico de diabetes, aunque no esté como antecedente. Eso sí, por estar en 7% está relativamente bien controlado. - La nefropatía diabética inicial tiene microalbuminuria (entre 30 y 300 mg de albuminuria en 24 horas), sin otras alteraciones. - La nefropatía diabética establecida tendría el antecedente de diabetes mal controlada de larga data, aunque rara vez evoluciona a un síndrome nefrótico, aunque puede hacerlo. Generalmente, la nefropatía diabética es más una insuficiencia renal crónica, con caída del clearence y elevación de la creatinina. - La GEFS sí produce síndrome nefrótico puro, pero está asociada a VIH y en pacientes más jóvenes (ej. adolescentes) o en raza negra. - La nefrosis lipoidea también produce un síndrome nefrótico puro, pero en niños.

Fuente: Nefrología, cuestionario 5.7, P4

43. Un hombre de 58 años, diabético tipo 2, en tratamiento con glibenclamida, más metformina desde hace varios años, presenta edema facial y de extremidades inferiores, asociado a orinas espumosas. El examen físico no aporta mayor información. Se solicitan exámenes que constatan un clearence de creatinina de 70 ml/min, BUN: 23 mg/dl, proteinuria de 24 horas de 5,1 gramos, sedimento de orina sin alteraciones y albuminemia de 2,2 g/dl. Hace un año, sus exámenes eran normales. El diagnóstico más probable es:

a. Glomeruloesclerosis difusa
b. Nefritis intersticial
c. Nefropatía membranosa
d. Nefrosis lipoídea
e. Insuficiencia renal terminal

Respuesta correcta: c. Nefropatía membranosa

Explicación: Tiene un síndrome nefrótico. Por ser adulto y diabético, es posible que sea una nefropatía diabética, pero, debido a lo rápido de su instalación (hace un año estaba normal) lo más probable es que sea una glomerulopatía (o nefropatía) membranosa (o extramembranosa).

Fuente: Nefrología, cuestionario 5.8, P2

44. Un niño de 7 años presenta un cuadro de anasarca, asociado a orinas espumosas. Al examen físico presenta edema de párpados y extremidades e hidrocele. Se solicitan exámenes entre los que destaca una proteinuria de 80 mg/m2/hora, con índice proteinuria creatininuria: 3,8 y albuminemia: 2,9 g/dl. El sedimento de orina es normal, al igual que la creatinina plasmática y los electrolitos. El diagnóstico más probable es:

a. Nefropatía membranosa
b. Glomeruloesclerosis focal y segmentaria
c. Nefropatía por cambios mínimos
d. Síndrome hemolítico urémico
e. Glomerulonefritis postestreptocócica

Respuesta correcta: c. Nefropatía por cambios mínimos

Explicación: Tiene un síndrome nefrótico: proteinuria en rango nefrótico (mayor a 40 mg/m2/h o IP/C mayor a 3), hipoalbuminemia y anasarca (edema generalizado). Además es un síndrome nefrótico puro, porque no hay HTA, hematuria ni falla renal. Por ser un niño, lo más probable es que sea una nefropatía por cambios mínimos, también llamada nefrosis lipoidea. No requiere de biopsia renal, a menos que no responda a los corticoides o que se sospeche que no es una enfermedad de cambios mínimos (ej. es síndrome nefrótico impuro o adulto). Se trata con corticoides orales: prednisona 60 mg/m2 de superficie corporal al día, por 6 semanas, seguido de 40 mg/m2 por 4 semanas más; puede ser más corto si responde rápido: ej. 60 mg/Kg hasta que responda más 1 mes y luego otro mes de 40 mg/m2. - La A (nefropatía membranosa) también produce un síndrome nefrótico puro, pero afecta a adultos, en especial a diabéticos, mieloma, uso de fármacos, lupus. - La B (GEFS) también produce un síndrome nefrótico puro, pero afecta más a adolescentes y a pacientes con VIH, aunque también puede ser secundaria a diabetes, anemia de células falciformes, entre otras causas. - La D (SHU) es una insuficiencia renal aguda, grave, sin síndrome nefrótico, con anemia hemolítica y plaquetopenia y además puede tener hamaturia dismórfica. - La E (GNAP) suele cursar con un síndrome nefrítico y no nefrótico.

Fuente: Nefrología, cuestionario 5.8, P3

45. Un niño de 6 años presenta aumento de volumen facial y la madre refiere que su orina se ha vuelto muy espumosa. Al examen físico, presenta signos vitales; sin embargo, se aprecia edema de extremidades inferiores y de cara. Se solicitan exámenes, que muestran creatinina 0,5 mg/dl, electrolitos plasmáticos normales, proteinuria de 60 mg/m2/hora, sedimento de orina normal, ANCA (-), ANA(-), complemento normal, albúmina plasmática: 2,5 mg/dl, colesterol: 250 mg/dl, glicemia: 80 mg/dl. El diagnóstico más probable es:

a. Nefropatía por cambios mínimos
b. Nefropatía por IgA
c. Glomerulonefritis aguda postestreptocócica
d. Lupus sistémico
e. Síndrome hemolítico urémico

Respuesta correcta: a. Nefropatía por cambios mínimos

Explicación: Es un niño, con un síndrome nefrótico: proteinuria en rango nefrótico (mayor a 40 mg/m2/h), hipoalbuminemia y anasarca (edema generalizado). Además es un síndrome nefrótico puro, porque no hay HTA, hematuria ni falla renal. Por ser un niño, lo más probable es que sea una nefropatía por cambios mínimos, también llamada nefrosis lipoidea. Se trata con corticoides orales en alta dosis (prednisona 60 mg/m2 por 6 semanas, seguido de 40 mg/m2 por 4 semanas) y no requiere biopsia renal, a menos que no responda a los corticoides, que sea impuro o en adultos (en otras palabras, cuando se sospecha que no es una nefrosis lipoidea, sino otra causa). - La B (Berger o nefropatía por IgA) es una glomerulonefritis, por lo que tiene hematuria dismórfica y solo rara vez hace un síndrome nefrítico completo y aún más rara vez con un síndrome nefrótico, que sería impuro. - La C (GNAPE) suele cursar con un síndrome nefrítico y no nefrótico. - La D (LES) también es nefrítico, con hematuria, aunque puede hacer un síndrome nefrótico, cuando se complica con una nefropatía membranosa secundaria (autoinmune con anticuerpos antipodocitos, como los anti-PLA2R). - La E (SHU) es una insuficiencia renal aguda, grave, sin síndrome nefrótico, con anemia hemolítica y plaquetopenia y, además, puede tener hematuria dismórfica.

Fuente: Nefrología, cuestionario 5.8, P8

46. Un paciente diabético presenta un síndrome nefrótico, con edema que inició hace 3 meses, proteinuria objetivada de 6 gramos al día y clearence de creatinina de 90 ml/min. El diagnóstico más probable es:

a. Glomeruloesclerosis focal y segmentaria
b. Glomeruloesclerosis difusa
c. Nefropatía membranosa
d. Glomerulopatía a cambios mínimos
e. Nefropatía diabética

Respuesta correcta: c. Nefropatía membranosa

Explicación: - La nefropatía diabética suele presentarse inicialmente como proteinuria (en específico albuminuria) en rango no nefrótico, que evoluciona a insuficiencia renal crónica (caída del clearence de creatinina) y también, en algunos pocos casos, puede ir aumentando la proteinuria, hasta terminar como un síndrome nefrótico, pero que es de muy lenta instalación (demora años). Es la causa más frecuente de síndrome nefrótico en los diabéticos, pero también puede haber otras causas. - La nefropatía membranosa o extramembranosa es una enfermedad que actualmente se sabe es de índole autoinmune, con presencia de anticuerpos en contra de distintos antígenos de los podocitos (ej. anti-PLA2R). Suele presentarse como un síndrome nefrótico puro. Es la causa más frecuente de síndrome nefrótico en los adultos no diabéticos y también puede ser secundario a uso de fármacos, lupus y otras enfermedades. En

este caso, a pesar de ser diabético, por tener gran proteinuria, corto tiempo de evolución y función renal conservada, lo más probable es que sea una glomerulopatía membranosa. Aunque el clearence está normal, por tener daño renal, sigue existiendo una IRC, solo que en etapa I. - La A (GEFS) también produce un síndrome nefrótico puro, pero afecta más a adolescentes y a pacientes con VIH, aunque perfectamente podría ser este caso (la única forma de saber será con la biopsia renal). En adultos de raza negra es más frecuente que la nefropatía membranosa. - La B (glomeruloesclerosis) es causa de insuficiencia renal crónica, ejemplo asociado a HTA, pero no suele tener un síndrome nefrótico. - La D (cambios mínimos) sí produce un síndrome nefrótico puro, pero generalmente en niños. Puede darse en adultos, pero es menos frecuentes.

Fuente: Nefrología, cuestionario 5.8, P20

Síndrome nefrítico y glomerulonefritis (19)

47. Un niño de 10 años presenta un cuadro de malestar general, hematuria y aumento de volumen facial de 3 días de evolución. Al examen físico se constata presión arterial 140/90 mmHg y edema de párpados y de extremidades inferiores, con signo de la fóvea positivo. Se solicitan exámenes entre lo que destacan creatinina: 1,2 mg/dl y sedimento de orina con abundantes glóbulos rojos, con un 25% de dismorfia. Refiere haber presentado una faringitis, cuyos síntomas terminaron hace una semana. El diagnóstico más probable es:

a. Glomerulopatía por cambios mínimos
b. Glomerulonefritis rápidamente progresiva
c. Glomerulonefritis postestreptocócica
d. Enfermedad de Berger
e. Nefropatía por IgA

Respuesta correcta: c. Glomerulonefritis postestreptocócica

Explicación: Tiene una glomerulonefritis (hematuria dismórfica), con síndrome nefrítico: HTA, edema y hematuria. La GNAPE es la causa más frecuente de síndrome nefrítico en los niños. Además, el antecedente de faringitis hace muy sugerente una GNAPE. - La A (cambios mínimos) cursa con un síndrome nefrótico puro (en este caso no hay síndrome nefrótico y, si lo hubiera, sería impuro). - La B (GNRP) cursa además con una IRA severa, que no es el caso, ya que la creatinina está apenas en 1,2 mg/dl. - La enfermedad de Berger o nefropatía por IgA es un diagnóstico factible, pero suele cursar sin síndrome nefrítico (puede hacerlo) y no tiene el antecedente de una infección hace más de una semana (aunque sí se descompensa con las infecciones concomitantes tanto virales como bacterianas: ej. resfrío o faringitis ahora o hace menos de una semana).

Fuente: Nefrología, cuestionario 5.3, P4

48. Un paciente de 44 años presenta un cuadro de oliguria y hematuria, asociado a hemoptisis y disnea. En sus exámenes destaca creatinina de 4,0 mg/dl, hematuria con abundantes acantocitos y la biopsia renal que muestra un patrón lineal a la inmunofluorescencia. El diagnóstico más probable es:

a. Lupus eritematosos sistémico
b. Vasculitis de vaso pequeño
c. Púrpura trombocitopénico trombótico
d. Síndrome de Goodpasture
e. Púrpura de Schönlein Henoch

Respuesta correcta: d. Síndrome de Goodpasture

Explicación: Tiene un síndrome riñón-pulmón (glomerulonefritis más compromiso pulmonar: hemoptisis y disnea). En este caso, por haber una IRA grave, hay además una GNRP. Dado el patrón lineal, la única opción es la enfermedad de Goodpasture, también llamada síndrome de Goodgasture y, actualmente, también enfermedad por anticuerpos anti-membrana basal glomerular (ya sin la antigua distinción entre Goodpasture y antimembrana basal). - La A (LES) también puede producir un síndrome riñón pulmón, pero con patrón moteado en la biopsia. - La B (vasculitis) también puede cursar con esta clínica, pero tiene un patrón pauciinmune en la biopsia (sin depósito de anticuerpos). - La C (PTT) no tiene afectación pulmonar, pero sí cursa con una IRA grave, más plaquetopenia y hemólisis y afectación del sistema nervioso central y periférico. - La E (PSH) no afecta a los pulmones. Sí produce púrpura palpable, artritis, glomerulonefritis y afectación gastrointestinal.

Fuente: Nefrología, cuestionario 5.3, P8

49. ¿Cuál es el diagnóstico más probable ante un paciente con un síndrome nefrótico impuro, hematuria e hipocomplementemia?

a. Glomerulopatía por cambios mínimos
b. Glomerulonefritis postinfecciosa
c. Glomeruloesclerosis focal y segmentaria
d. Glomerulonefritis mesangiocapilar
e. Nefropatía por IgA

Respuesta correcta: d. Glomerulonefritis mesangiocapilar

Explicación: La GNMC se caracteriza por ser una glomerulonefritis hipocomplementémica y puede cursar con síndrome nefrítico o síndrome nefrótico, necesariamente impuro, ya que al ser una GN, siempre tiene hematuria. Su presentación es muy variable y es similar a la de otras glomerulonefritis (ej. mediada por IgA), con grados variable de falla renal, proteinuria y sintomatología, por lo que solo la hipocomplementemia permite sospecharla y, finalmente, solo la biopsia permite el diagnóstico adecuado. Es más un diagnóstico histológico que etiológico, ya que tiene múltiples causas: depósito de complejos inmunes (ej. VIH, VHB, VHC, infecciones bacterianas crónicas, lupus sistémico) o anticuerpos monoclonales (ej. mieloma múltiple u otras gamapatías) o por otras causas más raras (ej. disregulación de la vía alternativa de activación del complemento). Todas tienen en común ser hipocomplementémicas. El tratamiento más importante es tratar la causa. - La A (GP membranosa) y la C (GEFS) tienen el complemento normal y suelen producir síndrome nefrótico puro. - La B (GP postinfecciosa) tiene el complemento bajo, pero suele producir síndrome nefrítico. - La E (GN por IgA) tiene el complemento normal y suele producir solo hematuria, aunque puede tener falla renal o presentarse como un síndrome nefrítico. Es raro que sea nefrótica.

Fuente: Nefrología, cuestionario 5.3, P15

50. Una mujer de 20 años, evoluciona con un cuadro de malestar general y hematuria. Al examen físico se constata hipertensión arterial de 180/110 mmHg, FC: 80x', con edema de extremidades inferiores. La conducta más adecuada es:

a. Iniciar ciclofosfamida + corticoides
b. Solicitar ecografía-doppler abdominal y metanefrinas urinarias
c. Solicitar sedimento de orina y urocultivo, e iniciar antibióticos endovenosos a la espera del resultado
d. Realizar hemodiálisis de urgencia

e. Solicitar creatinina plasmática, BUN, proteinuria, electrolitos, sedimento de orina, ANA, ANCA y complemeto

Respuesta correcta: e. Solicitar creatinina plasmática, BUN, proteinuria, electrolitos, sedimento de orina, ANA, ANCA y complemeto

Explicación: Tiene un síndrome nefrítico: Hematuria, HTA y edema. Sin embargo, no tenemos ni la causa, ni se conoce el estado de la función renal, por lo que la primera conducta será estudiarlas. Esto se ve en la opción E, en la que la se piden los exámenes de función renal, más algunos exámenes inmunológicos, en busca de las causas más frecuentes. - La A (corticoides y ciclofosfamida) es el tratamiento de las GNRP, pero no conocemos el estado de la función renal, como para saberlo ni se ha hecho la biopsia renal. - La B (Doppler y metanefrinas) es parte del estudio de la HTA secundaria, pero en este caso no solo hay una HTA secundaria, sino un síndrome nefrítico completo, por lo que se asume que la HTA es secundaria a la glomerulonefritis. - La C sería correcta para el estudio de una PNA, pero no hay clínica sugerente. - No hay síndrome urémico, ni complicaciones graves y refractarias de una IRA, como para plantear la hemodiálisis.

Fuente: Nefrología, cuestionario 5.4, P7

51. Una paciente presenta lesiones en la piel de los dedos y posteriormente evoluciona con un síndrome nefrítico, asociado a hipocomplementemia. ¿Cuál de los siguientes diagnósticos es más probable?

a. Púrpura de Schönlein Henoch
b. Vasculitis de vaso pequeño
c. Nefrosis lipoidea
d. Crioglobulinemia
e. Glomeruesclerosis focal y segmentaria

Respuesta correcta: d. Crioglobulinemia

Explicación: La clínica puede ser tanto de una endocarditis bacteriana (las lesiones de los dedos podrían ser nódulos de Osler o lesiones de Janeway), como una crioglobulinemia, ya que ambas son hipocomplementémicas (junto con la GNAPE, el LES y la GNMC). Ninguna de las demás opciones baja el complemento. Además, la A (PSH) suele venir con afectación gastrointestinal, púrpura palpable de EEII y artritis. La B (vasculitis) suelen hacer una GNRP, con afectación sistémica importante. La C (cambios mínimos) y la E (GEFS) son causa de síndrome nefrótico puro.

Fuente: Nefrología, cuestionario 5.4, P9

52. Identifique la asociación correcta:

a. Glomeruloesclerosis focal y segmentaria – Síndrome nefrítico clásico
b. Glomerulonefritis membranoproliferativa – Síndrome nefrótico puro
c. Poliangeítis microscópica – Glomerulonefritis crescéntica, pauciinmune, con insuficiencia renal
d. Síndrome de Goodpasture – Hipocomplemetemia y hematuria
e. Lupus – Glomerulopatía con patrón lineal en la inmunofluorescencia

Respuesta correcta: c. Poliangeítis microscópica – Glomerulonefritis crescéntica, pauciinmune, con insuficiencia renal

Explicación: - La PAM es una vasculitis de vaso pequeño, las que suelen cursar con una GNRP, que en la biopsia se ve con formación de medialunas (GN crescéntica) y en la inmunofluorescencia no observa depósito de anticuerpos (pauciinmune). - La A (GEFS) produce un Sd. nefrótico, habitualmente impuro. - La B (GNMP) es lo mismo que la GNMC y como buena GN tiene hematuria, por lo que produce un Sd. nefrótico impuro, o bien solo un Sd. nefrítico o, por lo menos, hematuria dismórfica. Puede tener grados

variables de falla renal. Es hipocomplementémica. - La D (Goodpasture) produce un síndrome nefrítico, pero con complemento normal y tiene un patrón lineal en la IF. También puede tener un síndrome riñón pulmón. - La E (LES) tiene un patrón en cielo estrellado o moteado en la IF. Suele ser nefrítica, a menos que se le agregue una nefropatía membranosa, que es nefrótica.

Fuente: Nefrología, cuestionario 5.4, P16

53. ¿Cuál de las siguientes alteraciones es MENOS probable de presentarse en un paciente con una glomerulonefritis postestreptocócica?

a. Hipocomplementemia
b. Elevación discreta de la creatinina plasmática
c. Hipertensión arterial
d. Hematuria dismórfica
e. Aumento del hematocrito

Respuesta correcta: e. Aumento del hematocrito

Explicación: La GNAPE se caracteriza por ser un síndrome nefrítico (hematuria dismórfica, edema e HTA), con hipocomplementemia. Puede cursar con IRA, la que habitualmente es leve (opción B), aunque puede ser severa. La retención de volumen, tiene a producir una caída del hematocrito, de tipo dilucional, sin caída de la masa eritrocitaria. - La caída del hematocrito también se ve en SHU, IRC, lupus, entre otras cosas. - La IRA prerrenal, por el contrario, suele tener elevación del hematocrito por hemoconcentración.

Fuente: Nefrología, cuestionario 5.5, P5

54. Un niño de 12 años ha presentado hematuria en varias oportunidades. Se solicita urocultivo que resulta negativo y sedimento de orina que visualiza hematuria de 50 GR por campo, con 20% de dismorfia (acantocitos). No presenta otros síntomas y su examen físico es normal. El diagnóstico más probable es:

a. Síndrome nefrítico
b. Síndrome nefrótico
c. Síndrome hemolítico urémico
d. Necrosis tubular aguda
e. Glomerulonefritis aguda

Respuesta correcta: e. Glomerulonefritis aguda

Explicación: Tiene hematuria dismórfica, por lo que es diagnóstico de una glomerulonefritis aguda. No tiene ni HTA ni edema, por lo que no es un síndrome nefrítico. Tampoco tiene edema, proteinuria, hipoalbuminemia o dislipidemia, como para que sea síndrome nefrótico. No tiene insuficiencia renal, como para pensar en SHU o NTA. Además, por la edad y la clínica, lo más probable es que sea una nefropatía por IgA o enfermedad de Berger.

Fuente: Nefrología, cuestionario 5.5, P9

55. Un paciente de 30 años, con antecedente de sinusitis crónica de 3 meses de evolución, presenta marcado malestar general, asociado a hematuria, oliguria y fiebre. Al examen físico presenta edema de EEII, PA: 190/110 mmHg, FC: 90x'. En sus exámenes destaca creatinina: 6,5 mg/dl, BUN: 100 mg/dl, sedimento de orina con hematuria dismórfica y proteinuria de 24 horas de 2 gramos. El diagnóstico más probable es:

a. Síndrome hemolítico urémico
b. Necrosis tubular aguda

c. Nefritis intersticial
d. Glomerulonefritis rápidamente progresiva
e. Síndrome nefrótico impuro

Respuesta correcta: d. Glomerulonefritis rápidamente progresiva

Explicación: Tiene una glomerulonefritis aguda (hematuria dismórfica), más una insuficiencia renal grave (creatinina de 6,5 mg/dl y BUN de 100 mg/dl), lo que es diagnóstico de una GNRP. Por la edad, probablemente es una vasculitis de Wegener, que suele tener mucha afectación nasosinusal, además de renal, de nervio periférico y pulmonar (suele empezar nasosinusal). - El SHU (A) afecta a niños, está precedido por diarrea y tiene una IRA, la que sí puede acompañarse de hematuria dismórfica. - La NTA (B) no tiene hematuria, sino una IRA, con sodio urinario alto, FeNa elevado y cilindros granulosos y céreos. - La nefritis intersticial (C) tiene una IRA, asociada al uso de AINEs o diuréticos, con fiebre, exantema y eosinofilia. - El síndrome nefrótico (E) tiene proteinuria en rango nefrótico, edema, hipoalbuminemia, dislipidemia.

Fuente: Nefrología, cuestionario 5.6, P2

56. Un paciente presenta un síndrome nefrítico, asociada a hipocomplementemia. ¿Cuál de los siguientes diagnósticos es compatible con esto?

a. Enfermedad de Good Pasture
b. Lupus
c. Poliangeítis microscópica
d. Nefrosis lipoidea
e. Glomeruloesclerosis focal y segmentaria

Respuesta correcta: b. Lupus

Explicación: Las glomerulonefritis hipocomplementémicas son: GNAPE (la más importante), lupus, crioglobulinemia, asociada a EBSA y sepsis, GNMC y la asociada a shunt. La enfermedad de Goodpasture (enfermedad por anticuerpos antimembrana basal) y la PAM sí son nefríticas, pero normocomplementémicas. La nefrosis lipoidea y la GEFS son nefróticas y, además, normocomplementémicas.

Fuente: Nefrología, cuestionario 5.6, P8

57. Un niño de 6 años presenta un cuadro de edema y hematuria, que inició hace una semana. Al examen físico presenta edema de párpados y de EEII, asociado a hipertensión arterial. En sus exámenes destaca creatininemia: 1,2 mg/dl, proteinuria: 500 mg/dl, sedimento de orina con 50 eritrocitos por campo, con un 20% de dismorfia y descenso del complemento. El diagnóstico más probable es:

a. Síndrome hemolítico urémico
b. Enfermedad de Berger
c. Síndrome nefrítico
d. Síndrome nefrótico puro
e. Síndrome nefrótico impuro

Respuesta correcta: c. Síndrome nefrítico

Explicación: Tiene un síndrome nefrítico clásico: HTA, edema y hematuria dismórfica. Además, por la hipocomplementemia y la edad, lo más probable es que sea una GNAPE. La A (SHU) tiene una IRA grave (no es el caso, ya que la creatinina solo ligeramente elevada). La B (Berger) es normocomplementémica. No tiene síndrome nefrótico, ya que no tiene proteinuria en rango nefrótico.

Fuente: Nefrología, cuestionario 5.7, P5

58. Un paciente de 34 años presenta una glomerulonefritis rápidamente progresiva, con creatininemia 5,0 mg/dl, asociado a hemoptisis e infiltrados pulmonares en la radiografía de tórax. Su complemento es normal, con ANA negativo y ANCA negativo. Se realiza una biopsia renal, con inmunofluorescencia, que muestra un patrón lineal de IgG en los glomérulos. El diagnóstico más probable es:

a. Enfermedad de Berger
b. Glomerulonefritis mesangiocapilar
c. Poliangeítis microscópica
d. Lupus eritematoso sistémico
e. Síndrome de Goodpasture

Respuesta correcta: e. Síndrome de Goodpasture

Explicación: Tiene un síndrome riñón pulmón (GN más alveolitis hemorrágica). El patrón lineal confirma el diagnóstico de síndrome de Goodpasture, actualmente llamada enfermedad por anticuerpos anti-membrana basal. - La A (Berger) y la B (GNMC) no tienen afectación pulmonar. - La C (PAM) y la D (LES) sí pueden producir un síndrome riñón-pulmón, pero el LES tiene ANA(+) y patrón moteado en la IF; y la PAM tiene ANCA(+) y patrón pauciinmune. Por cultura general, dejo una imagen de un patrón lineal:

Fuente: Nefrología, cuestionario 5.7, P9

59. Un paciente de 18 años consulta por malestar general y orinas oscuras. Al examen físico presenta edema de las extremidades inferiores, con signo de la fóvea positiva y sus signos vitales son FC: 71x', PA: 180/110 mmHg, t°: 36,5°C. Se solicitan exámenes que muestran creatininemia de 1,1 mg/dl, BUN: 24 mg/dl, natremia: 140 mEq/L, potasemia: 4,3 mEq/L, sedimento de orina con 80 GR por campo, con 35% de dismorfia e índice proteinuria/creatinininuria: 0,5. El diagnóstico más probable es:

a. Síndrome hemolítico urémico
b. Síndrome nefrítico
c. Síndrome nefrótico impuro
d. Síndrome nefrótico puro
e. Glomerulonefritis aguda rápidamente progresiva

Respuesta correcta: b. Síndrome nefrítico

Explicación: Tiene la triada del síndrome nefrítico: hematuria, hipertensión y edema. Además tiene una glomerulonefritis (hematuria dismórfica). No tiene síndrome nefrótico, porque para comenzar, no tiene proteinuria en rango nefrótico (necesitaría un IP/C mayor a 3 y solamente es 0,5 en este caso). No puede ser una GNRP porque la creatinina está normal y la GNRP (glomerulonefritis rápidamente progresiva), por definición tiene una IRA grave, asociada. Tampoco puede ser un SHU, porque afecta a los niños y cursa con IRA grave. Si bien falta información, lo más probable es que tenga una nefropatía por IgA (enfermedad de Berger) y, si se dijera que estuvo con amigdalitis hace más de 1-2 semanas o que tiene C3 y C4 bajas, se trataría de una GNAPE (glomerulonefritis postestreptocócica).

Fuente: Nefrología, cuestionario 5.8, P3

60. Los cilindros eritrocitarios son característicos de:

a. Nefritis intersticial
b. Glomerulonefritis
c. Necrosis tubular
d. Pielonefritis

e. Hemorragia de origen urológico

Respuesta correcta: b. Glomerulonefritis

Explicación: El sedimento de orina es la forma como se diagnostica la glomerulonefritis, con la presencia de cilindros eritrocitarios (o hemáticos) o de hematuria dismórfica (acantocitos). - La nefritis intersticial tiene eosinófilos en el sedimento. - La NTA tiene células tubulares (epiteliales), cilindros céreos y/o granulosos en el sedimento (hay veces en que el sedimento es normal, por lo que la clínica más la FeNa suelen ser las que permiten el diagnóstico y no solo el sedimento). - La PNA tiene leucocituria y piocituria, más eventualmente cilindros piocitarios. - La hemorragia de origen urológico tiene hematuria sin dismorfia, ni cilindros. De hecho, la diferencia entre hematuria glomerular y urológica se hace en base a la presencia o ausencia de dismorfia, respectivamente.

Fuente: Nefrología, cuestionario 5.8, P5

61. Mujer de 22 años, con cuadro de 5 días de evolución de odinofagia, fiebre leve y rinorrea. Presenta varios episodios de hematuria indolora. Al examen físico está hipertensa, con edema en las extremidades inferiores. La analítica demuestra hemograma sin anemia, con 5.000 blancos por mm3 y 160.000 plaquetas por mm3, creatinina: 1,3 mg/dl, complemento C3 y C4 dentro de rangos normales, proteinuria de 1,3 gramos en 24 horas. El sedimento de orina muestra eritrocitos dismórficos abundantes. El diagnóstico más probable es:

a. Nefropatía por IgA
b. Poliangeítis granulomatosa (de Wegener)
c. Síndrome nefrótico impuro
d. Glomerulopatía membranosa
e. Lupus eritematoso sistémico

Respuesta correcta: a. Nefropatía por IgA

Explicación: Tiene una glomerulonefritis y algún grado de falla renal. También tiene un síndrome nefrítico (hipertensión, edema y hematuria). No tiene proteinuria en rango nefrótico, por lo que no hay un síndrome nefrótico impuro ni puede ser la glomerulopatía membranosa. Tiene el complemento normal, lo que sugiere que es por depósitos de IgA y se vuelve muy improbable el LES. Si bien es posible que se trata de una vasculitis de Wegener, le falta la agresividad del cuadro, la afectación de más órganos y, además, es mucho menos frecuente que la enfermedad de Berger o nefropatía por IgA.

Fuente: Nefrología, cuestionario 5.8, P6

62. Una paciente de 30 años presenta un cuadro de malestar y hematuria, seguida de oliguria. En su sedimento de orina presenta hematuria dismórfica y su laboratorio sanguíneo da cuenta de una creatininemia de 5,4 mg/dl. Se realiza una biopsia renal, que muestra una glomerulonefritis con formación de medialunas (crescéntica), con una inmunofluorescencia que no visualiza anticuerpos (pauciinmune). El diagnóstico más probable es:

a. Síndrome de Goodpasture
b. Lupus eritematosos sistémico
c. Enfermedad de Berger
d. Glomerulonefritis membranoproliferativa
e. Vasculitis de vaso pequeño

Respuesta correcta: e. Vasculitis de vaso pequeño

Explicación: Tiene una glomerulonefritis (hematuria dismórfica), rápidamente progresiva (con caída rápida del clearence de creatinina), cuya causa más frecuente son las vasculitis de vaso pequeño, pro también pueden verse en otros cuadros (LES, Goodpasture). La biopsia muestra una glomerulonefritis crescéntica, que es la histología característica de las GNRP, independiente de la causa. Solo la imnunofluorescencia da el diagnóstico en este caso, ya que al ser pauciinmune, la única opción es una vasculitis de vaso pequeño, probablemente granulomatosis de Wegener (actualmente llamada "granulomatosis con poliangitis"), dado la edad de la paciente, aunque también hay casos de poliangitis microscópica. - La A (Goodpasture) tiene un patrón lineal en la IF. - La B (LES) tiene un patrón moteado o en cielo estrellado en la IF. - La C (enfermedad por depósito de complejos inmunes IgA o enfermedad de Berger) tiene un patrón moteado, para IgA y generalmente no cursa con falla renal tan grave ni agresiva, aunque hay casos en que sí desarrolla síndrome nefrítico y falla renal. - La D (GNMP o GNMC mesangiocapilar) no tiene un patrón crescéntico, sino mesangiocapilar y se caracteriza por un síndrome nefrótico impuro, con hipocomplementemia. Comentario importante: la regla general es que las glomerulonefritis se biopsian, a menos que 1. se sospeche fuertemente una GNAPE (posestreptocócica) sin falla renal o 2. haya solo hematuria dismórfica sin hipertensión, proteinuria ni falla renal, en que se sospecha una nefropatía por IgA. En resto se biopsia, en especial cuando hay falla renal (GNRP), ya que tratar la etiología específica puede hacer la diferencia entre una completa remisión y el daño renal permanente.

Fuente: Nefrología, cuestionario 5.8, P6

63. Una paciente de 32 años presenta una glomerulonefritis rápidamente progresiva, por lo que se decide solicitar una biopsia renal, la que muestra glomérulos con proliferación celular y formaciones semilunares (glomerulonefritis crescéntica) y patrón pauciinmune en la inmunofluorescencia. El diagnóstico más probable es:

a. Lupus sistémico eritematoso
b. Enfermedad de Berger (nefropatía por IgA)
c. Vasculitis de vaso pequeño
d. Síndrome de Good-Pasture
e. Nefrosis lipoidea

Respuesta correcta: c. Vasculitis de vaso pequeño

Explicación: Tiene una glomerulonefritis rápidamente progresiva (GNRP), cuya causa más frecuente son las vasculitis de vaso pequeño, pero también pueden verse en otros cuadros (LES, Goodpasture). La biopsia muestra una glomerulonefritis crescéntica, que es la histología característica de las GNRP, independiente de la causa. Solo la imnunofluorescencia da el diagnóstico en este caso, ya que, al ser pauciinmune (sin depósito de anticuerpos), la única opción es una vasculitis de vaso pequeño (probablemente granulomatosis de Wegener (actualmente llamada granulomatosis con poliangeítis), dado la edad de la paciente; en cambio la PAM (poliangeítis microscópica) afecta más a adultos mayores). Las vasculitis de vaso pequeño suelen ser ANCA positivas (Wegener: ANCA-c; PAM: ANCA-p) y se tratan con corticoides endovenosos más inmunodepresores (actualmente se prefiere el rituximab a la ciclofosfamida). Sin tratamiento tienen altísima letalidad, pero actualmente la gran mayoría de los pacientes logra remitir. - La A (LES) tiene un patrón moteado o en cielo estrellado en la IF. - La B (Berger) tiene un patrón moteado, para IgA y generalmente no cursa con falla renal tan grave ni agresiva. - La D (Goodpasture) tiene un patrón lineal en la IF. - La E (nefrosis lipoidea) cursa con un síndrome nefrótico puro, sin hematuria ni falla renal.

Fuente: Nefrología, cuestionario 5.8, P6

64. Un niño de 8 años presenta un cuadro de hematuria y edema palpebral. En su examen físico se constata edema blando de párpados y de extremidades inferiores, asociado a presión arterial en percentil 99 para su edad, sexo y talla. Se solicitan exámenes generales, entre los que destaca una creatininemia de 1,3 mg/dl y un BUN de 22 mg/dl. El diagnóstico más probable es:

a. Enfermedad de Berger
b. Glomeruloesclerosis focal y segmentaria
c. Nefrosis lipoidea
d. Glomerulonefritis postestreptocócica
e. Síndrome hemolítico urémico

Respuesta correcta: d. Glomerulonefritis postestreptocócica

Explicación: Es un niño que tiene un síndrome nefrítico, ya que cursa con hematuria, hipertensión y edema. Recordemos que la hipertensión en niños se diagnostica con PA en percentil mayor o igual a p95 (para la talla, sexo y edad) en 3 ocasiones. Además está con una ligera insuficiencia renal (crea mayor a 1,1). La única opción aceptable es la D, ya que la GNAPE es la causa más frecuente de síndrome nefrítico en pediatría. - La A (Berger) suele cursar solo con hematuria y solo rara vez hace un síndrome nefrítico completo. Sin embargo es una alternativa posible y hubiese sido correcto si dijera, por ejemplo, que tenía historia de episodios previos o que actualmente está resfriado (ya que se descompensa con las infecciones, pero habitualmente en los primeros 7 días, mientras que la GNAPE suele presentarse después de 10 días de iniciada la infección estreptocócica). - La B (GEFS) y la C (nefrosis lipoidea) son causa de síndrome nefrótico. - La E (SHU) es una insuficiencia renal aguda grave (crea estaría más elevada) más anemia hemolítica y plaquetopenia, aunque sí puede tener HTA e incluso hematuria dismórfica, aunque no es propiamente tal una glomerulonefritis, sino una microangiopatía agresiva.

Fuente: Nefrología, cuestionario 5.8, P11

65. Una paciente cursa con una glomerulonefritis aguda con complementemia disminuida, ¿Cuál de los siguientes diagnósticos es MENOS probable?

a. Lupus
b. Glomerulonefritis asociada a Shunt
c. Poliangetis microscópica
d. Glomerulonefritis asociada a endocarditis bacteriana
e. Crioglobulinemia

Respuesta correcta: c. Poliangetis microscópica

Explicación: Las GNA con complemento bajo son las siguientes: 1. GNAPE, 2. LES, 3. Crioglobulinemia, 4. GN por complejos inmunes, asociada a EBSA y a sepsis y 5. GN por shunt. En resumen, son todas las por depósitos de complejos inmunes tipo IgG, ya que la por IgA suele ser normocomplementémica. El infarto renal y la embolia renal por colesterol, también pueden ser hipocomplementémicos. Las vasculitis de vaso pequeño suelen ser normocomplementémicas.

Fuente: Nefrología, cuestionario 5.8, P12

Nefropatía diabética (4)

66. Un paciente de 65 años, diabético tipo 2, mal controlado, acude a control y refiere astenia y malestar general. En sus exámenes destaca una creatinina de 2,8 mg/dl, con proteinuria de 1 gramo al día y sedimento de orina normal. No se había realizado exámenes desde hace 5 años, momento en que estaban normales. El diagnóstico más probable es:

a. Glomerulopatía membranosa
b. Glomeruloesclerosis focal y segmentaria
c. Nefropatía diabética
d. Glomerulonefritis rápidamente progresiva
e. Glomeruloesclerosis difusa

Respuesta correcta: c. Nefropatía diabética

Explicación: Tiene una insuficiencia renal, dado que la creatinina está elevada y lo primero a descartar es que sea una insuficiencia renal aguda, dado que hace algunos años sus exámenes estaban normales. Sin embargo, lo más probable es que sea crónica. Además tiene proteinuria, pero no en rango nefrótico, lo que sugiere alguna glomerulopatía (ya sea glomerulonefritis u otra enfermedad glomerular). Por ser diabético, lo más probable es que sea una nefropatía diabética. - La A (glomerulopatía membranosa) produce un síndrome nefrótico (no es el caso). - La B (GEFS) también produce un síndrome nefrótico. - La D (GNRP) produce una IRA agresiva y además cursa con hematuria dismórfica. - La E (GE difusa) es característica de la nefropatía HTA.

Fuente: Nefrología, cuestionario 5.3, P2

67. Paciente diabético de 45 años, en tratamiento con metformina y control irregular de sus glicemias por mala adherencia a tratamiento. Su presión arterial es 120/78. En sus exámenes de control destaca creatinina: 0,9 mg/dl; BUN: 12 mg/dl; proteinuria: 200 mg/día); albuminuria: 130mg/día, RAC: 120. Tres meses antes sus exámenes había mostrado cifras muy similares. La conducta más adecuada, además de mejorar el control de sus glicemias, es:

a. Sospechar glomerulopatía membranosa y solicitar albuminemia y perfil lipídico
b. Suspender hipoglicemiantes orales e iniciar insulina
c. Realizar biopsia renal
d. Agregar enalapril al tratamiento
e. Iniciar prednisona

Respuesta correcta: d. Agregar enalapril al tratamiento

Explicación: Solo tiene microalbuminuria (Relación albuminuria creatininuria (RAC) mayor a 30 o albuminuria mayor a 30 mg/día), por lo tanto, tiene una nefropatía diabética inicial y se debe agregar enalapril, aunque sus presiones arteriales estén normales (en diabetes se prefiere <130/80). No tiene proteinuria, por lo que no puede ser una nefropatía membranosa. No tiene falla renal, por lo que tampoco está indicada la insulina (crea desde 1,5 obliga a usar insulina o los nuevos HGO).

Fuente: Nefrología, cuestionario 5.8, P4

68. En un paciente adulto, diabético de larga data, con mal control metabólico, actualmente está cursando un síndrome nefrótico puro. Se solicitan exámenes, que objetivan creatinina 1,8 mg/dl (hace un año 1,65 mg/dl), y proteinuria estimada de 3,6 g/dl, con sedimento de orina con 2 glóbulos rojos por campo. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

a. Nefropatía diabética inicial

b. Glomerulopatía membranosa
c. Glomerulonefritis mesangiocapilar
d. Nefropatía por IgA
e. Nefropatía diabética establecida

Respuesta correcta: e. Nefropatía diabética establecida

Explicación: Tiene una nefropatía diabética establecida, por tener daño renal, con elevación de la creatinina. La nefropatía diabética también es la causa más frecuente de síndrome nefrótico en el paciente diabético de larga data y mal control metabólico. Eso sí, solo la biopsia renal podrá dar un diagnóstico de certeza, ya que es posible que haya otras causas de síndrome nefrótico. - La A (nefropatía diabética inicial) se caracteriza por microalbuminuria (mayor a 30 mg/día), pero con la proteinuria total normal, función renal normal y sin síndrome nefrótico. - La B (nefropatía membranosa) también da síndrome nefrótico puro, pero, por ser autoinmune, se suele instalar más rápido que la nefropatía diabética, habitualmente en algunos meses y, además, suele tener niveles de proteinuria mucho más elevados. - La C (GNMC) tendría hematuria, hipocomplementemia y proteinuria (síndrome nefrótico impuro o nefrítico). - La D (nefropatía por IgA = Enfermedad de Berger) suele cursar solo con hematuria (es una glomerulonefritis) o con síndrome nefrítico y es muy improbable que sea nefrótica y, en caso de serlo, es impuro, por la hematuria propia de las glomerulonefritis.

Fuente: Nefrología, cuestionario 5.8, P7

69. Un paciente de 68 años, diabético, está en tratamiento con metformina y dieta. ¿Qué examen le parece más adecuado para predecir el inicio del daño renal?

a. Albuminuria de 24 horas
b. Fracción excretada de sodio
c. Sedimento de orina
d. Ecografía abdominal
e. Clearence de creatinina

Respuesta correcta: a. Albuminuria de 24 horas

Explicación: En el paciente diabético, la nefropatía inicial se diagnostica mediante la albuminuria de 24 horas. Si está elevada (mayor a 30 mg/día) tiene riesgo de progresar a una nefropatía establecida, con caída del clearence de creatinina. La B (FeNa) se usa para diferenciar la IRA renal de la IRA prerrenal. La D (ecografía) sirve para diferencias la IRA, de la IRC, cuando no se sabe el tiempo de evolución.

Fuente: Nefrología, cuestionario 5.8, P13

Trastornos hidroelectrolíticos (24)

70. Un paciente se pierde en una excursión. Pasa 48 horas sin tomar agua y al momento de ser encontrado presenta compromiso de conciencia. El diagnóstico más probable es:

a. Hiperkalemia
b. Hipokalemia
c. Hipernatremia
d. Hiponatremia
e. Hipercalcemia

Respuesta correcta: c. Hipernatremia

Explicación: La privación de agua produce hipernatremia. Recordar que las entradas y salidas de agua determinan la natremia, mientras que las entradas y salidas de sodio, determinan la volemia. Además, la hipernatremia puede producir hemorragias cerebrales, debido a la disminución de volumen del cerebro, que tracciona y rompe algunas venas; también puede haber mielinolisis pontina (similar a la que ocurre en la corrección rápida de la hiponatremia). Tanto la hipernatremia, como la hiponatreamia y la hipercalcemia producen compromiso de conciencia. Las alteraciones del potasio, en cambio, no producen afectación cerebral.

Fuente: Nefrología, cuestionario 5.3, P1

71. Es efecto adverso de la hidroclorotiazida, todo lo siguiente, EXCEPTO:

a. Hipernatremia
b. Hipokalemia
c. Hiperuricemia
d. Dislipidemia
e. Hipercalcemia

Respuesta correcta: a. Hipernatremia

Explicación: Las tiazidas producen hiponatremia y no hipernatremia. Sí producen hipokalemia, hipercalcemia y además alteraciones metabólicas, como dislipidemia, hiperuricemia y resistencia a la insulina. Los diuréticos de asa (furosemida) tienen los mismos efectos adversos, salvo que tienden a la hipocalcemia (porque aumentan la excreción de calcio). Por eso la furosemida se usa como parte del manejo de la hipercalcemia, mientras que la HCTZ se usa en el manejo de la hipercalciuria primaria.

Fuente: Nefrología, cuestionario 5.3, P7

72. Un paciente de 68 años presenta un cuadro de malestar general y debilidad de 4 días de evolución, asociado a poliuria y constipación y luego compromiso de conciencia. Al examen físico está en sopor superficial, con deshidratación evidente, sin focalidad neurológica. El cuadro clínico descritos es compatible con

a. Hipofosfemia
b. Hipocalcemia
c. Hipokalemia
d. Hiperkalemia
e. Hipercalcemia

Respuesta correcta: e. Hipercalcemia

Explicación: Si bien, en este caso, lo primero será solicitar una glicemia capilar, porque puede ser un síndrome hiperglicémico hiperosmolar o una hipoglicemia, también es compatible con una hipercalcemia. La hipercalcemia produce constipación, debilidad, poliuria, deshidratación y compromiso de conciencia (la constipación no se ve en los problemas diabéticos mencionados). La poliuria se produce por una diabetes insípida nefrogénica, secundaria a la hipercalcemia, pero también se ve en la diabetes mellitus descompensada. - La hipofosfemia aguda severa cursa con compromiso de conciencia, hemólisis y rabdomiólisis (déficit agudo de ATP produce daño celular). - La hipokalemia no afecta la conciencia y produce debilidad y arritmias, con alargamiento del QT, que pueden terminar en una torsión de puntas (taquicardia ventricular polimorfa). - La hiperkalemia no afecta el SNC, pero sí produce debilidad y arritmias (fibrilación auricular, bloqueos AV y taquicardias ventriculares), con ondas T picudas, QRS ancho y acortamiento del QT. - La hipocalcemia produce tetania (ROT aumentados, contracturas musculares),

más debilidad y parestesias peribucales. También puede alargar el QT y complicarse con arritmias ventriculares severas, tipo torsión de puntas.

Fuente: Nefrología, cuestionario 5.3, P11

73. Identifique la asociación INCORRECTA entre el fármaco y la alteración provocada por este:

a. Furosemida – hipocalcemia
b. Enalapril – hiperkalemia
c. Amiloride – hiperkalemia
d. Ibuprofeno – hipokalemia
e. Espironolactona – hiperkalemia

Respuesta correcta: d. Ibuprofeno – hipokalemia

Explicación: Los AINES, como el ibuprofeno, producen hiperkalemia, ya que tienen a disminuir la filtración renal. Los demás fármacos sí producen las alteraciones descritas.

Fuente: Nefrología, cuestionario 5.3, P14

74. La primera medida, frente a un paciente con una hiperkalemia grave, con alteraciones electrocardiográficas, es:

a. Administrar suero fisiológico
b. Administrar gluconato de calcio
c. Administrar suero glucosado con insulina
d. Administrar sulfato de magnesio
e. Administrar bicarbonato de sodio

Respuesta correcta: b. Administrar gluconato de calcio

Explicación: Las hiperkalemias severas evolucionan con arritmias ventriculares malignas, que pueden ser muy graves. Para evitarlas, se debe administrar, como medida más urgente, calcio endovenoso, habitualmente como gluconato de calcio (solo si hay catéter venoso central, se puede administrar como cloruro de calcio). Luego se administra insulina más glucosa EV con o sin salbutamol nebulizado y, además, se toman medidas para disminuir el potasio corporal, como dieta baja en potasio, diuréticos y resinas de intercambio. - El SF es la primera medida en la hipovolemia y en la hipercalcemia. - El gluconato de calcio también es la primera medida en la hipocalcemia y la hpermagnesimia. - El bicarbonato de sodio es la medida más urgente en la acidosis metabólica grave, con pH menor a 6,9 en el caso de la cetoacidosis o menor a 7,1 en otras causas. - En la acidosis respiratoria no se usa el bicarbonato, sino que se debe conectar a ventilación mecánica.

Fuente: Nefrología, cuestionario 5.3, P19

75. Un paciente de 80 años, es traído por compromiso de conciencia. Al examen físico se encuentra deshidratado, en sopor profundo. Se solicitan exámenes, entre los que destaca una calcemia de 16 mg/dl. La conducta inicial más adecuada es:

a. Administrar gluconato de calcio endovenoso
b. Administrar sulfato de magnesio endovenoso
c. Administrar furosemida endovenosa
d. Administrar solución salina de NaCl al 0,9% por vía endovenosa
e. Administrar suero glucosado e insulina por vía endovenosa

Respuesta correcta: d. Administrar solución salina de NaCl al 0,9% por vía endovenosa

Explicación: El tratamiento de la hipercalcemia grave es 1. Suero fisiológico endovenoso y luego, 2. Bifosfonatos endovenosos y 3. Calcitonina endovenosa. La furosemida de algo puede servir. Además, en caso de que sea secundaria aun cáncer hematológico, son útiles los corticoides EV.

Fuente: Nefrología, cuestionario 5.4, P1

76. El uso prolongado de hidroclorotiazida puede producir todo lo siguiente, excepto

a. Hiponatremia
b. Hipocalcemia
c. Hipokalemia
d. Hiperuricemia
e. Hiperlipidemia

Respuesta correcta: b. Hipocalcemia

Explicación: Las tiazidas producen hipercalcemia y no hipocalcemia. Sí producen hipokalemia, hiponatremia y además alteraciones metabólicas, como dislipidemia, hiperuricemia y resistencia a la insulina.

Fuente: Nefrología, cuestionario 5.4, P4

77. Un paciente presenta una hipokalemia severa, que no responde al tratamiento médico habitual con administración de KCl en goteo y que tiene alteraciones en el electrocardiograma (alargamiento del QT, con salvas de taquicardia ventricular). La conducta más adecuada es:

a. Administrar 1 gramo de KCl en bolo
b. Administrar 3 gramos de KCl en bolo
c. Administrar gluconato de calcio endovenoso
d. Solicitar magnesemia y administrar sulfato de magnesio endovenoso
e. Realizar hemodiálisis de urgencia

Respuesta correcta: d. Solicitar magnesemia y administrar sulfato de magnesio endovenoso

Explicación: Ante una hipokalemia refractaria, siempre se debe sospechar una hipomagnesemia. La clínica de la hipomagnesemia es muy similar a la de la hipokalemia, es decir debilidad, alargamiento del QT y arritmias ventriculares (Torsión de puntas). Administrar KCl en bolo (opciones A y B) constituye un delito de homicidio, ya que nunca se debe administrar potasio en bolo, porque produce paro en asistolia. El gluconato de calcio sirve para la hiperkalemia, hipermagnesemia e hipocalcemia severas. La hemodiálisis se puede usar en la hiperkalemia grave y refractaria a tratamiento médico, lo que no se debe confundir con la hipokalemia refractaria, en la que se debe descartar la hipomagnesemia.

Fuente: Nefrología, cuestionario 5.4, P15

78. Un paciente de 50 años, insuficiente renal, por diabetes, presenta una natremia de 130. No presenta síntomas relacionados con dicha alteración. ¿Qué indicación es la más adecuada para el manejo de su hiponatremia?

a. Aumentar la ingesta de sal
b. Indicar espironolactona
c. Indicar furosemida
d. Indicar IECA
e. Restringir la ingesta de agua

Respuesta correcta: e. Restringir la ingesta de agua

Explicación: Las hiponatremias leves, independientes de su causa, se pueden observar, manejando su causa de base. La restricción del agua libre sirve para su manejo, aunque se debe sopesar el riesgo e incomodidad de tener a un paciente sediento con la necesidad de subir la natremia; por regla general, la restricción de agua está indicada en la IRC y cuando hay edema. En este caso, la causa probablemente es la IRC misma. - Aumentar la ingesta de sal, no subirá la natremia, sino la volemia. - La espironolactona y furosemida producen mayor hiponatremia. - El IECA no tiene mayor repercusión en la natremia.

Fuente: Nefrología, cuestionario 5.4, P19

79. Un paciente de 69 años, diagnosticado de cáncer de esófago, presenta un cuadro de astenia de una semana de evolución, que en las últimas horas empeora, apareciendo compromiso de conciencia. Al examen físico presenta sopor profundo, sin signos focales neurológicos. Se solicitan exámenes generales, entre los que destaca calcemia de 15,8 mg/dl. La conducta inicial más adecuada es:

a. Administrar corticoides por vía endovenosa
b. Administrar suero glucosado endovenoso
c. Administrar suero fisiológico endovenoso
d. Administrar furosemida endovenosa
e. Administrar zolendronato endovenoso

Respuesta correcta: c. Administrar suero fisiológico endovenoso

Explicación: El tratamiento de la hipercalcemia grave es 1. Suero fisiológico endovenoso (opción C) y luego, 2. Calcitonina (acción rápida) y Bifosfonatos, en especial el ácido zolendrónico (estabilizan el hueso y atacan la génesis, desde el punto de vista fisiopatológico). La primera medida, sin duda es la hidratación, aunque hay guías que recomiendan no retrasar los demás fármacos. De algo puede servir la furosemida (opción D). Además, en caso de que sea secundaria aun cáncer hematológico (no es el caso), son útiles los corticoides EV (opción A).

Fuente: Nefrología, cuestionario 5.5, P2

80. Un paciente de 68 años, cardiópata coronario, en tratamiento con aspirina, enalapril, carvedilol y espironolactona, presenta bradicardia de 46x'. Se solicita electrocardiograma que muestra ondas T picudas y ensanchamiento del complejo QRS. ¿Cuál es la primera medida para el tratamiento de este paciente, ante la sospecha diagnóstica?

a. Administrar suero fisiológico
b. Administrar insulina
c. Administrar gluconato de calcio
d. Administrar suero hipotónico (glucosalino)
e. Administrar cloruro de potasio endovenoso

Respuesta correcta: c. Administrar gluconato de calcio

Explicación: Tiene una hiperkalemia severa, por las alteraciones electrocardiográficas: ondas T picudas, QRS ancho y bradicardia. Es urgente tratarla. La primera medida es el gluconato de calcio, ya que el calcio estabiliza la membrana miocárdica y evita la aparición de arritmias malignas (taquicardia ventricular). - El SF es de elección en la hipercalcemia grave (y en la hipovolemia obviamente). - El calcio también sirve en la hipocalcemia y en la hipermagnesemia graves. - El suero hipotónico (suero glucosado o glucosalino) se usa en la hipernatremia grave. - El KCl (cloruro de potasio) sirve para la hipokalemia y nunca se pasa en bolo, sino siempre en goteo.

Fuente: Nefrología, cuestionario 5.6, P3

81. La diabetes insípida se caracteriza por:

a. Hiponatremia
b. Orinas concentradas
c. Responder a diuréticos de asa
d. Aparición de hipernatremia al suspender la ingesta de agua
e. Responder a la restricción de agua libre a menos de 800 cc/día

Respuesta correcta: d. Aparición de hipernatremia al suspender la ingesta de agua

Explicación: La diabetes insípida se produce por falta de producción de la ADH (central) o por falta de acción de la ADH (nefrogénica), lo que se traduce en pérdidas de agua, por vía renal, lo que genera hipernatremia. El paciente compensa la hipernatremia, tomando mucha agua, pero, al privarlo de agua, se objetiva la aparición de hipernatremia, manteniendo orinas diluidas (test de la sed o de privación de agua). El tratamiento de la diabetes insípida es dar aguda y, si es central, se administra desmopresina (análogo de la ADH). Finalmente, privar de agua a un paciente con diabetes insípida tiene riesgo de hipernatremias graves y muerte. - En cambio el síndrome de secreción inadecuada de ADH (SSIADH), es lo opuesto a la diabetes insípida y produce hiponatremia, tiene orinas concentradas y responde a la privación de agua (opciones A, B y E).

Fuente: Nefrología, cuestionario 5.6, P6

82. Un paciente sufre un TEC severo, con un hematoma subdural, que debe ser manejado con neurocirugía. En el postoperatorio evoluciona bien, con recuperación de la conciencia y sin secuelas neurológicas, sin embargo 3 días después se constata hiponatremia, con Na plasmático de 130 mEq/L. La conducta más adecuada para el manejo de esta alteración electrolítica es:

a. Administrar suero fisiológico endovenoso
b. Indicar aumento de la ingesta de sal
c. Administrar desmopresina intranasal
d. Administrar suero hipertónico al 3% por vía endovenosa
e. Restringir la ingesta de agua libre a 800cc/día

Respuesta correcta: e. Restringir la ingesta de agua libre a 800cc/día

Explicación: La sospecha es un síndrome de secreción inadecuada de ADH (SSIADH), dado que tiene hiponatremia, más el antecedente de una afectación del SNC (el TEC en este caso) y también por el dolor posquirúrgico. Muchas de las causas de hiponatremia, se tratan con restricción de la ingesta de agua libre y, en el caso del SSIADH, es la indicación más importante, buscándose una ingesta de agua menor a 800cc/día. Solo si es que cursan con compromiso de conciencia o con hiponatremia grave, menor a 120 mEq/l, se administra el suero hipertónico, lento (máximo corregir 8 mEq/L al día), ya que la corrección rápida de la hiponatremia se asocia a mielinolisis pontina. - El aumento de la ingesta de sodio solo produce hipervolemia y no corrige la hiponatremia, que depende de la retención de agua.

Fuente: Nefrología, cuestionario 5.7, P2

83. Un paciente de 70 años presenta un cuadro de desorientación y luego sopor, que fue precedido por constipación, astenia y poliuria de algunos días de duración. Al examen físico está soporoso y deshidratado. ¿Qué alteración hidroelectrolítica es compatible con el cuadro clínico descrito?

a. Hiperkalemia
b. Hipercalcemia
c. Hipernatremia

d. Hiponatremia
e. Hipocalcemia

Respuesta correcta: b. Hipercalcemia

Explicación: Es una hipercalcemia clásica, por la clínica (constipación, poliuria, deshidratación, compromiso de conciencia). Algo importante es que, salvo la constipación, todo ello se puede ver en síndrome hiperglicémicos. - La hiperkalemia (A) cursa con debilidad, ondas T picudas, QRS ancho y acortamiento del QT, sin compromiso de conciencia. - La hipernatremia (C) se presenta como hemorragias cerebrales. Sí puede asociarse a poliuria (diabetes insípida), deshidratación y compromiso de conciencia, pero le sobraría la constipación. De todos modos, se debe medir la natremia también. - La hiponatremia (D) produce edema cerebral, con cefalea, vómitos y compromiso de conciencia. Generalmente no tiene ni poliuria, ni deshidratación. - La hipocalcemia (E) se presenta como un cuadro de tetania, parestesias peribucales y alargamiento del QT.

Fuente: Nefrología, cuestionario 5.7, P7

84. Un paciente insuficiente renal crónico terminal está una semana sin ir a dializarse, evolucionando con debilidad generaliza y marcado compromiso del estado general. Su electrocardiograma muestra lo siguiente: El diagnóstico más probable es:

a. Hiponatremia
b. Hipocalcemia
c. Hipercalcemia
d. Hipokalemia
e. Hiperkalemia

Respuesta correcta: e. Hiperkalemia

Explicación: Tiene las ondas T altas y picudas características de la hiperkalemia. Además, la clínica de debilidad y el antecedente de IRC, también la sugieren.

Fuente: Nefrología, cuestionario 5.8, P1

85. Una paciente de 60 años, fumadora de 30 paquetes año, consulta por cefalea de 1 semana de evolución, sin otros síntomas. Entre sus exámenes destaca hiponatremia de 127 mEq/L. ¿Cuál es la conducta inicial más adecuada, mientras se realiza el estudio etiológico?

a. Indicar un diurético inhibidor de la aldosterona
b. Indicar un diurético de asa
c. Restringir la ingesta de agua
d. Indicar un inhibidor de la enzima convertidora de angiotensina o del receptor de angiotensina 2
e. Indicar un diurético tiazídico

Respuesta correcta: c. Restringir la ingesta de agua

Explicación: El manejo inicial de toda hiponatremia leve (sin síntomas neurológicos graves) es la privación de agua libre. Entre las causas de hiponatremia está el SSIADH, que se asocia a patología pulmonar (ej. cáncer de pulmón, dado que era muy fumadora).

Fuente: Nefrología, cuestionario 5.8, P5

86. Identifique la asociación INCORRECTA entre el fármaco y su efecto en el balance hidroelectrolítico:

a. Amiloride - Hipokalemia
b. Enalapril - Hiperkalemia

c. Furosemida - Hipocalcemia
d. Hidroclorotiazida - Hiponatremia
e. Espironolactona - Hiponatremia

Respuesta correcta: a. Amiloride - Hipokalemia

Explicación: El amiloride es un diurético ahorrador de potasio, ya que es un bloqueador del ENaC (canal epitelial de sodio), al igual que el triamterene. También son ahorradores de potasio los bloqueadores del receptor de aldosterona, como la espironolactona y la eplerenona (derivado de la espironolactona, pero que tiene menos efectos antiandrogénico y progestágeno). Todos los diuréticos ahorradores de potasio producen hiperkalemia. Por el contrario, los diuréticos de asa (furosemida, torsemida) y las tiazidas (hidroclorotiazida, clortalidona, indapamida) producen hipokalemia (la clortalidona tiene más riesgo de hipokalemia que la HCTZ). Las demás opciones son verdaderas.

Fuente: Nefrología, cuestionario 5.8, P5

87. Paciente con mieloma múltiple, evoluciona con poliuria y constipación de 3 días de evolución, agregándose en las últimas horas deshidratación y compromiso de conciencia. El diagnóstico más probable es:

a. Hipermagnesemia
b. Hipercalcemia
c. Hipofosfemia
d. Hiponatremia
e. Hipernatremia

Respuesta correcta: b. Hipercalcemia

Explicación: Es una hipercalcemia maligna clásica, tanto por el antecedente de un mieloma, como por la clínica (constipación, poliuria, deshidratación, compromiso de conciencia). - La hipermagnesemia cursa con debilidad y acortamiento del QT y la única causa relevante es la intoxicación con MgSO4 en el tratamiento de la preclamsia. - La hipofosfemia aguda se presenta como un cuadro de hemólisis, rabdomiólisis y psicosis (déficit agudo de ATP), habitualmente en relación a desnutrición, en especial en el síndrome de realimentación. La hipofosfemia crónica, en cambio, se asocia a osteomalacia. - La hiponatremia produce edema cerebral, con cefalea, vómitos y compromiso de conciencia. Generalmente no tiene ni poliuria, ni deshidratación. - La hipernatremia se presenta como hemorragias cerebrales. Sí puede asociarse a poliuria (diabetes insípida), deshidratación y compromiso de conciencia, pero le sobraría la constipación.

Fuente: Nefrología, cuestionario 5.8, P11

88. Son efectos esperables en un paciente que usa furosemida, EXCEPTO:

a. Hiperlipidemia
b. Hiperuricemia
c. Hipocalcemia
d. Hiperkalemia
e. Hiponatremia

Respuesta correcta: d. Hiperkalemia

Explicación: La furosemida, como diurético de asa, produce pérdidas de agua, sodio, cloro y potasio. Por tanto, tiende a la hipokalemia. Tanto las tiazidas, como los diuréticos de asa, produce dislipidemia, resistencia a la insulina e hiperuricemia. Además ambos producen hiponatremia, hipocloremia e

hipokalemia. La diferencia está en el calcio, ya que la furosemida produce hipocalcemia y HCTZ produce hipercalcemia.

Fuente: Nefrología, cuestionario 5.8, P14

89. Un paciente de 60 años acude al servicio de urgencia por síncopes y debilidad. Su examen físico sólo muestra bradicardia de 48 lpm. Se solicita un electrocardiograma que muestra bradicardia, ondas T picudas y ensanchamiento del complejo QRS. Se solicitan electrolitos plasmáticos que muestran potasio: 7,2 mEq/L y sodio: 130 mEq/L. La primera medida es:

a. Administrar sulfato de magnesio endovenoso
b. Administar suero fisiológico endovenoso
c. Administrar gluconato de calcio endovenoso
d. Administrar insulina endovenosa
e. Administrar suero hipertónico endovenoso

Respuesta correcta: c. Administrar gluconato de calcio endovenoso

Explicación: Tiene una hiperkalemia severa (mayor a 6,5) y además con alteraciones electrocardiográficas (ondas T picudas, QRS ancho y bradicardia), por lo que es urgente tratarla. Son indicaciones de tratamiento urgente: 1. Alteraciones del EKG (única indicación absoluta), 2. clínica de debilidad y parálisis y/o 3. K+>6,5 mEq/L. El tratamiento incluye 4 medidas, las que se realizan todas, en el siguiente orden: * Primero: Estabilizar la membrana miocárdica con calcio endovenoso (ej. gluconato de calcio 1g en bolo EV): evita la aparición de arritmias malignas (taquicardia ventricular). * Segundo: Fármacos que ingresen el potasio a las células: insulina cristalina endovenosa (más glucosa para evitar hipoglicemias). Es aceptable dar, junto a la insulina, salbutamol. * Tercero: Medidas que reduzcan el potasio corporal: dar diuréticos, resinas de intercambio, hemodiálisis. * Cuarto: tratar la causa de base: ej. ajustar fármacos. - El MgSO4 se usa en la preclamsia con exaltación neurológica. - El SF es de elección en la hipercalcemia grave (y en la hipovolemia obviamente) - El calcio también sirve en la hipocalcemia y en la hipermagnesemia graves. - El suero hipertónico se usa en la hiponatremia grave y se debe administrar lento, para evitar la mielinolisis pontina.

Fuente: Nefrología, cuestionario 5.8, P16

90. Un paciente de 67 años, hipertenso y portador de una insuficiencia renal crónica, usuario de Losartán, presenta marcado malestar del estado general, constatándose una hiperkalemia grave, con compromiso del ritmo cardíaco. La conducta más adecuada es:

a. Administrar suero fisiológico y diuréticos de asa endovenosos
b. Realizar hemodiálisis de urgencia
c. Administrar gluconato de calcio e iniciar insulina más suero glucosado por vía endovenosa
d. Administrar sulfato de magnesio endovenos e iniciar nebulizaciones con salbutamol
e. Iniciar insulina cristalina en suero glucosado y realizar nebulizaciones con salbutamol

Respuesta correcta: c. Administrar gluconato de calcio e iniciar insulina más suero glucosado por vía endovenosa

Explicación: Dado que tiene una hiperkalemia grave, la conducta más urgente es administrar el gluconato de calcio, para estabilizar la membrana miocárdica y evitar arritmias ventriculares. Luego sirven la insulina + glucosa endovenosa (se puede agregar el salbutamol en nebulizaciones), para ingresar el potasio a las células y, además, tomar medidas para disminuir el potasio corporal total, como diuréticos o resinas de intercambio. El tratamiento mencionado es obligatorio en toda hiperkalemia con afectación electrocardiográfica y, según algunos autores, también en las hiperkalemias con K+ mayor a 6,5 mEq/L o

con sintomatología de debilidad o parálisis. Además, en este caso será importante suspender el losartán (causante de la hiperkalemia, junto a la IRC) y reemplazarlo por otro fármaco.

Fuente: Nefrología, cuestionario 5.8, P16

91. Un paciente con antecedente de insuficiencia renal crónica en etapa predialítica presenta en sus exámenes Na:130mEq/l, K:4,7mEq/l, Cl:99mEq/l. Se encuentra en buenas condiciones y su examen físico solo muestra edema de extremidades inferiores. El tratamiento más adecuado para su hiponatremia es:

a. Restricción de agua libre
b. Aumentar la ingesta de sodio
c. Agregar un diurético de asa
d. Administrar suero hipertónico por vía endovenosa
e. Hemodiálisis

Respuesta correcta: a. Restricción de agua libre

Explicación: La hiponatremia leve y moderada asintomática (sin compromiso neurológico y mayor a 120 mEq/L) por regla general, se trata solo con medidas generales, tales como corrección de la causa (ej. ajuste de diuréticos o manejo de la polidipsia primaria) y restricción de agua, en especial en pacientes con SSIADH (se da menos de 800 cc/día), IRC, DHC y pacientes con edema. En este caso, la causa de la hiponatremia es la IRC misma. Si la hiponatremia es severa (<120 mEq/L) o sintomática (ej. HTEC, compromiso de conciencia, convulsiones, etc.), se prefiere el suero hipertónico EV (NaCl al 3%), con corrección lenta, para evitar la mielinólisis pontina. - Es correcto dar 100 cc de suero hipertónico al 3% rápido en los casos severos, agudos o sintomáticos, pero el resto se suele dar más lento y la corrección diaria total no debe ser más de 8 mEq/L, ya que, si es muy rápida, tiene riesgo de generar mielinolisis pontina, complicación muy grave. - Aumentar la ingesta de sodio, no arregla la natremia, sino que produce hipervolemia e hipertensión. - Los diuréticos de asa pueden agravar la hiponatremia (aunque tienen un buen clearence de agua libre, por lo que no suelen producir hiponatremias muy severas). - La diálisis, generalmente no tiene mucha utilidad como manejo de la hiponatremia, ya que suele responder bien a las otras medidas mencionadas, pero sí es importante mantener el balance del sodio en los pacientes que están en diálisis.

Fuente: Nefrología, cuestionario 5.8, P18

92. Un paciente de 40 años, intenta correr una maratón como aficionado. Para mantenerse hidratado toma abundante agua durante la carrera, sin embargo, evoluciona con compromiso de conciencia y convulsiones algunos kilómetros antes de terminar. El diagnóstico más probable es:

a. Hipernatremia
b. Hipercalemia
c. Hiperalcemia
d. Hiponatremia
e. Hipocalcemia

Respuesta correcta: d. Hiponatremia

Explicación: La hiponatremia relacionada con el ejercicio ha sido ampliamente descrita y se produce por pérdidas de sodio en el sudor y, especialmente, por reposición excesiva con agua o fluidos hiposódicos. Por eso hoy se recomienda hidratarse con líquidos isotónicos y no en exceso. Se caracteriza por afectación del sistema nervioso central, iniciando con náuseas y mareos y terminando con compromiso de conciencia y convulsiones. Ante estos síntomas se debe medir inmediatamente el sodio y, si no está disponible, incluso es aceptable dar 100 cc de suero hipertónico. - Se debe tener cuidado con no confundirla con la

hipernatremia del deportista, que ocurre en pacientes con severa deshidratación (por no tomar líquidos), por lo que en el paciente shockeado no es aceptable asumir que haya una hiponatremia, puesto que también puede haber una hipernatremia. - Otra cosa nefrológica del maratonista, es la proteinuria normal que se produce con el ejercicio.

Fuente: Nefrología, cuestionario 5.8, P19

93. Un paciente de 68 años sufre un traumatismo encéfalo-craneano grave, con formación de un hematoma subdural, el que es manejado quirúrgicamente. Evoluciona unos días después con compromiso de conciencia, por lo que se solicita un TAC de cerebro de control, que es compatible con un edema cerebral. ¿Qué alteración electrolítica es más probable, como causante del cuadro en este paciente?

a. Hipernatremia
b. Hiperkalemia
c. Hiponatremia
d. Hipercalcemia
e. Hipocalcemia

Respuesta correcta: c. Hiponatremia

Explicación: La hiponatremia es causa de edema cerebral. En este caso está producida por un SSIADH, secundario al TEC complicado. La hipernatremia se asocia a deshidratación y se presenta como hemorragias cerebrales. La hiperkalemia no afecta el SNC, sino que produce debilidad y arritmias. La hipercalcemia produce constipación, debilidad, poliuria, deshidratación y compromiso de conciencia. La hipocalcemia produce tetania (ROT aumentados, contracturas musculares), más debilidad y parestesias peribucales.

Fuente: Nefrología, cuestionario 5.8, P20

Trastornos del equilibrio ácido-base (6)

94. Un paciente presenta los siguientes gases venosos: pH: 7,50; CO2: 25 mmHg; HCO3: 20 mEq/L. El diagnóstico más probable, entre los siguientes, es:

a. Vómitos
b. Diarrea
c. Crisis de pánico
d. Intoxicación con aspirina
e. Intoxicación con benzodiacepinas

Respuesta correcta: c. Crisis de pánico

Explicación: Tiene el pH elevado, por lo que hay una alcalemia. Además, el CO2 está bajo (menor a 35), por lo que hay una alcalosis respiratoria, por la hiperventilación. De las opciones, solo la crisis de pánico produce hiperventilación. Lo vómitos producen alcalosis metabólica (pérdidas de ácido). La diarrea produce acidosis metabólica (pérdidas de becarbonato). La intoxicación con aspirina produce una acidosis metabólica, con alcalosis respiratoria. La intoxicación con BDZ procude una acidosis respiratoria, con hipoventilación.

Fuente: Nefrología, cuestionario 5.3, P3

95. Un paciente presenta los siguientes gases arteriales: PaO2: 60 mmHg, PaCO2: 44 mmHg, HCO3: 16 mEq/L, pH: 7,18. El diagnóstico ácido base es:

a. Acidosis respiratoria sola

b. Acidosis metabólica sola
c. Acidosis respiratoria con alcalosis metabólica
d. Acidosis metabólica con alcalosis respiratoria
e. Acidosis respiratoria y metabólica

Respuesta correcta: e. Acidosis respiratoria y metabólica

Explicación: Tiene el pH muy bajo, así que hay una acidosis. Además, el HCO3 está bajo, por lo que hay una acidosis metabólica, sin duda. En las acidosis metabólicas puras, el valor de la PaCO2 suele ser similar al número que está después del "7,__", en el pH. Sin embargo, en este caso el CO2 está en 44 mmHg y el número después del pH es 18, por lo que el CO2 está muy elevado para lo esperado. Por tanto, a pesar de que el CO2 está dentro del rango normal (35 a 45 mmHg), hay también una acidosis respiratoria.

Fuente: Nefrología, cuestionario 5.3, P12

96. Un paciente presenta los siguientes gases venosos pH 7,40; HCO3: 15 mEq/L; CO2: 25 mmHg. El diagnóstico del estado ácido base es:

a. Acidosis metabólica, con alcalosis respiratoria
b. Alcalosis metabólica, con acidosis respiratoria
c. Acidosis mixta
d. Acidosis metabólica pura
e. Equilibrio ácido-base normal

Respuesta correcta: a. Acidosis metabólica, con alcalosis respiratoria

Explicación: Es una pregunta difícil, porque el pH está normal. Sin embargo, el bicarbonato está muy bajo, lo que indica que hay una acidosis metabólica y por otro lado, el CO2 está muy bajo, lo que indica que hay una hiperventilación con alcalosis respiratoria. Ambas alteraciones se anulan en su efecto en el pH, por lo que está normal (7,4).

Fuente: Nefrología, cuestionario 5.4, P3

97. Un paciente presenta los siguientes gases venosos: pH: 7,49 , HCO3: 33 mEq/L, CO2: 45 mmHg. ¿Qué alternativa es compatible con estos gases?

a. Diarrea abundante
b. Vómitos abundantes
c. Cetoacidosis diabética
d. Insuficiencia renal crónica
e. Crisis de pánico con hiperventilación

Respuesta correcta: b. Vómitos abundantes

Explicación: Tiene una alcalosis de tipo metabólica (pH alto, HCO3 alto y CO2 en el límite normal- alto). La única opción que produce eso son los vómitos (pérdidas de ácido clorhídrico). La diarrea y la IRC producen acidosis metabólica con anion-gap normal (pérdida de bicarbonato). La cetoacidosis también tiene acidosis metabólica con anion-gap aumentado (presencia de un ácido orgánico). La crisis de pánico produce alcalosis respiratoria.

Fuente: Nefrología, cuestionario 5.4, P20

98. Un paciente presenta una diarrea aguda abundante. ¿Cuál de las siguientes alternativas es más compatible con las alteraciones ácido-base esperables?

a. pH: 7,31; HCO3: 17 mEq/L; CO2: 35 mmHg

b. pH: 7,45; HCO3: 30 mEq/L; CO2: 45 mmHg
c. pH: 7,48; HCO3: 18 mEq/L; CO2: 25 mmHg
d. pH: 7,27; HCO3: 26 mEq/L; CO2: 58 mmHg
e. pH: 7,11; HCO3: 14 mEq/L; CO2: 45 mmHg

Respuesta correcta: a. pH: 7,31; HCO3: 17 mEq/L; CO2: 35 mmHg

Explicación: La diarrea aguda suele cursar con pérdidas de bicarbonato, por lo que tiene una acidosis metabólica pura, con anion gap normal. La A es la única con acidosis metabólica pura. La B tiene una alcalosis metabólica. La C tiene una alcalosis respiratoria. La D tiene una acidosis respiratoria. La E tiene una acidosis mixta (pH bajo, HCO3 bajo y CO2 demasiado alto, para lo esperable, ya que para un pH de 7,11, se espera un CO2 cercano a 11).

Fuente: Nefrología, cuestionario 5.8, P2

99. Una mujer presenta los siguientes gases de sangre arterial: pH: 7,52, CO2: 24 mmHg, HCO3: 19 mEq/L. El diagnóstico ácido base es:

a. Alcalosis metabólica
b. Alcalosis metabólica con acidosis respiratoria
c. Alcalosis respiratoria
d. Alcalosis mixta
e. Acidosis metabólica compensada

Respuesta correcta: c. Alcalosis respiratoria

Explicación: Tiene el pH elevado (> 7,44), por lo que hay una alcalemia. Además, el CO2 está muy bajo (menor a 35 mmHg), por lo que es una alcalosis respiratoria, secundaria a la hiperventilación. El HCO3 también bajó, pero solo por equilibrio químico (si baja el CO2, baja el HCO3)

Fuente: Nefrología, cuestionario 5.8, P12

Hipertensión arterial y causas secundarias (12)

100. El hiperaldosteronismo primario se presenta como una hipertensión arterial secundaria, que suele acompañarse característicamente de:

a. Hiperkalemia
b. Hipernatremia
c. Hipokalemia
d. Hiponatremia
e. Elevación de la renina plasmática

Respuesta correcta: c. Hipokalemia

Explicación: Lo más característico de la HTA por HAP es la marcada hipokalemia, dado que la aldosterona aumenta la excreción de potasio. En la HTA renovascular también hay hipokalemia, ya que se eleva la renina, activándose el eje renina-angiotensina- aldosterona, produciéndose un hiperaldosteronismo secundario, que también genera hipokalemia. La diferencia entre HAP y RV se realiza con los exámenes (índice aldosterona/renina y doppler de arterias renales, respectivamente), pero orienta a HAP una hipokalemia severa o sintomática (calambres, debilidad muscular), la edad joven y la presencia de adenomas o hiperplasia suprarrenales. En cambio, orienta a RV la mayor edad, la presencia de enfermedad ateromatosa (enfermedad arterial periférica, aneurisma aórtico, enfermedad coronaria) u

otra causa de estenosis arterial (ej. displasia fibromuscular), la caída del clearence de creatinina con IECAs o ARA2, la atrofia renal unilateral y la presencia de soplos renales.

Fuente: Nefrología, cuestionario 5.3, P10

101. Un paciente de 60 años, hipertenso en tratamiento con hidroclorotiazida 50 mg al día, acude a control, presentando presiones arteriales promedio de 150/100 mmHg. No presenta daño a órgano blanco y su estudio descartó la presencia de una hipertensión secundaria. La conducta más adecuada es:

a. Agregar furosemida al tratamiento
b. Agregar enalapril al tratamiento
c. Agregar amlodipino al tratamiento
d. Remplazar la hidroclorotiazida por losartán
e. Mantener el tratamiento

Respuesta correcta: b. Agregar enalapril al tratamiento

Explicación: Ver resumen de tratamiento farmacológico de la HTA. Es una HTA mal controlada. Como sus presiones arteriales están en 150/100 Por lo que requiere dos fármacos. Por regla general cuando se inicia la HCTZ, no se varía la dosis, aunque el rango aceptable sea 50 a 100 mg/día. Se suele agregar un IECA o ARA2, ya que tienen el efecto contrario a la HCTZ en la potasemia.

Fuente: Nefrología, cuestionario 5.3, P17

102. ¿Cuál de las siguientes alteraciones es más compatible con un hiperaldosteronismo primario?

a. Hipotensión
b. Hiperkalemia
c. Hiponatremia
d. Hipokalemia
e. Elevación de la renina plasmática

Respuesta correcta: d. Hipokalemia

Explicación: Lo más característico de la HTA por HAP es la marcada hipokalemia, dado que la aldosterona aumenta la excreción de potasio. En la HTA renovascular también hay hipokalemia, ya que se eleva la renina, activándose el eje renina-angiotensina- aldosterona, produciéndose un hiperaldosteronismo secundario. No hay hipotensión, sino hipertensión. No hay hiponatremia, sino tendencia a una leve hipernatremia.

Fuente: Nefrología, cuestionario 5.4, P14

103. Un paciente de 48 años diagnosticado de hipertensión arterial hace tres meses, acude a control. No tiene otras enfermedades y está en tratamiento con dieta hiposódica y medidas generales. Se realiza toma de presión arterial que muestra PA: 138/88. Él refiere que ha presentado cifras similares en los últimos días. La conducta más adecuada es:

a. Mantener el tratamiento y controlar en 3 meses
b. Iniciar un IECA
c. Iniciar una tiazida
d. Iniciar un diurético de asa
e. Iniciar un ARA II

Respuesta correcta: a. Mantener el tratamiento y controlar en 3 meses

Explicación: Es una pregunta actualmente muy difícil de responder, ya que existe mucha discusión sobre el objetivo de presión arterial que se debe lograr. La mayoría de las recomendaciones están tendiendo a mantener niveles de PA lo más bajas posible (ej. ideal <130/80, incluso quienes proponen <125-120/90), sin embargo, la evidencia de estas recomendaciones es muy débil, ya que no hay pruebas consistentes de beneficios, en comparación con el objetivo habitual de PA <140/90 para los adultos sanos. En este caso, se cumplió el objetivo de PA menor a 140/90 con las medidas no farmacológicas que se intentaron. Por tanto, la respuesta que dejaremos correcta es mantener el tratamiento. Sin embargo, también habría sido correcto iniciar un IECA o ARA2 desde el inicio y, en estricto rigor, lo más correcto es conversar con el paciente, explicarle el dilema científico y que él decida informado. - El objetivo cambia en pacientes con alto riesgo cardiovascular o de daño renal, como los pacientes con DM2, IRC, enfermedad ateromatosa (en lo que no queda duda que el valor de PA debe ser<120-130/80). - En el mayor de 75 años es discutible el objetivo. Sin embargo, el más aceptado en este momento es PA <150-140/90, sin perjuicio de que hay cada vez más autores que creen que todo el mundo, incluyendo los adultos mayores, debería tener menos de 130/80 de PA.

Fuente: Nefrología, cuestionario 5.5, P3

104. Un paciente de 80 años, previamente sano, presenta cefalea y tinitus, constatándose PA: 180/120, sin otras alteraciones en el examen físico. En sus exámenes generales destaca creatininemia: 1,1 mg/dl, sedimento de orina normal, natremia: 140 mEq/L, potasemia: 3,0 mEq/L, calcemia: 10 mEq/L. El diagnóstico más probable es:

a. Hipertensión esencial
b. Hipertensión renovascular
c. Hipertensión secundaria a nefropatía médica
d. Feocromocitoma
e. Hipertensión “del delantal blanco”

Respuesta correcta: b. Hipertensión renovascular

Explicación: Tiene una HTA secundaria (inicio después de los 55 años, severa, con crisis hipertensivas y con hipokalemia). La hipokalemia orienta a HTA renovascular y a hiperaldosteronismo primario (no está en las alternativas). Por ser adulto mayor, la sospecha es HTA renovascular por obstrucción ateromatosa de una arteria renal. - La HTA esencial sería más eleve y habría iniciado antes de los 55 años. - La glomerulopatía médica tiene elevación de la creatinina (insuficiencia renal) y tendencia a la hiperkalemia. - El feocromocitoma tiene crisis de palpitaciones, cefalea, sudoración, pánico e hipertensión. - La HTA del delantal blanco no tiene ninguna alteración, más allá de la HTA que aparece porque el paciente se pone muy nervioso al ser examinado por el médico. En cambio, en su casa tiene PA normales. Por eso, si se sospecha, se debe solicitar un Holter de presión arterial. Caso final, para que se aprenda a reconocer, un caso de HTA esencial clásico: Un paciente de 40 años, previamente sano, acude a control, constatándose PA: 144/90, sin otras alteraciones en el examen físico. En sus exámenes generales destaca creatininemia: 0,7 mg/dl, sedimento de orina normal, natremia: 140 mEq/L, potasemia: 4,5 mEq/L, calcemia: 9,5 mEq/L.

Fuente: Nefrología, cuestionario 5.5, P10

105. Un paciente de 48 años es diagnosticado de hipertensión arterial por un perfil de presión arterial. Inicia medidas generales y dieta hiposódica, controlándose 3 meses después, con presiones arteriales cercanas a 144/90. La conducta más adecuada es:

a. Mantener las indicaciones
b. Iniciar atenolol
c. Iniciar enalapril

d. Iniciar nifedipino
e. Iniciar nitroglicerina

Respuesta correcta: c. Iniciar enalapril

Explicación: Tiene una HTA mal controlada, que no respondió a las medidas generales no farmacológicas (actualmente se inician fármacos desde el inicio, de acuerdo a múltiples recomendaciones internacionales), por lo que es necesario iniciar fármacos. Por tener menos de 55 años, se suele iniciar con un IECA (enalapril) o con una ARA2 (losartán). En estricto rigor, todos las familias de antihipertensivos son aceptables, por lo que sí sería correcto un bloquedor del calcio (pero, amlodipino, ya que el nifedipino está obsoleto). El atenolol es aceptable, pero tiene muchos efectos adversos y una eficacia probablemente algo menor.

Fuente: Nefrología, cuestionario 5.6, P4

106. Un paciente de 20 años es diagnosticado de hipertensión arterial, mediante un Holter de presión. Se solicitan exámenes generales entre los que destacan cretininemia: 1,4 mg/dl, Na: 138 mEq/L, K: 2,0 mEq/L, Cl: 102 mEq/L, Ca: 10,0 mg/dl. El paciente había consultado por sentirse débil, con calambres frecuentes en las extremidades inferiores y cefalea. El diagnóstico más probable es:

a. Hipertensión esencial
b. Hipertensión renovascular
c. Hiperaldosteronismo primario
d. Feocromocitoma
e. Nefropatía médica, con hipertensión secundaria

Respuesta correcta: c. Hiperaldosteronismo primario

Explicación: Tiene una HTA secundaria (inicio antes de los 30 años, con hipokalemia). La hipokalemia orienta a HTA renovascular y a hiperaldosteronismo primario (HAP). Por ser joven puede ser tanto un hiperaldosteronismo primario, como una HTA renovascular por displasia fibromuscular de una arteria renal. Así que estrictamente es una mala pregunta. Sin embargo, la clínica de hipokalemia (debilidad, calambres) es más sugerente del HAP. La HTA esencial tendría K+ normal y habría iniciado después de los 30 años. La glomerulopatía médica tiene elevación de la creatinina (insuficiencia renal) y tendencia a la hiperkalemia. El feocromocitoma tiene crisis de palpitaciones, cefalea, sudoración, pánico e hipertensión.

Fuente: Nefrología, cuestionario 5.7, P1

107. Un paciente de 65 años, diagnosticado de hipertensión arterial esencial, en tratamiento con hidroclorotiazida 50 mg al día, presenta presiones arteriales cercanas a 145/95 en la mayoría de sus controles. La conducta más adecuada es:

a. Aumentar la dosis de hidroclorotiazida a 50 mg cada 12 horas
b. Agregar enalapril 10 mg cada 12 horas
c. Agregar amlodipino 5 mg al día
d. Agregar losartán 50 mg al día
e. Mantener el tratamiento y controlar en 3 meses

Respuesta correcta: b. Agregar enalapril 10 mg cada 12 horas

Explicación: Es una HTA mal controlada. Como no sabemos sus PA iniciales, no sabemos la severidad basal. Por regla general cuando se inicia la HCTZ, no se varía la dosis, aunque el rango aceptable sea 50 a 100 mg/día. Por ello, se debe agregar un nuevo fármaco y habitualmente se agrega un IECA o un ARA2. De todos modos, lo más correcto, habría sido solicitar electrolitos plasmáticos y creatinina antes de escoger

el segundo fármaco. Actualmente, muchas recomendaciones aconsejan iniciar con dos fármacos simultáneamente (ej. enalapril más amlodipino; losartán más HCTZ; etc.).

Fuente: Nefrología, cuestionario 5.7, P10

108. Un paciente de 50 años, hipertenso, en tratamiento con enalapril 10 mg cada 12 horas, acude a control médico. Presenta presión arterial de 150/90, la que es compatible con el registro de presiones arteriales, que ha realizado en su casa, con presiones promedio de 148/90 mmHg. Su creatininemia es 0,9 mg/dl y sus electrolitos muestran Na: 140 mEq/L, K:4,9 mEq/L. La conducta más adecuada es:

a. Cambiar el enalapril por losartán
b. Mantener el enalapril y agregar losartán
c. Cambiar el enalapril por hidroclorotiazida
d. Mantener el enalapril y agregar hidroclorotiazida
e. Agregar triamterene al tratamiento

Respuesta correcta: d. Mantener el enalapril y agregar hidroclorotiazida

Explicación: Tiene mal control de su presión arterial, ya que está sobre el objetivo (<140/90). No sabemos si está en etapa I o II, ya que no nos entregan las presiones arteriales previas al inicio de tratamiento. No tiene mayores patologías ni contraindicaciones de los fármacos, por lo que lo que define esta pregunta es el potasio. Como está normal, pero en el límite alto, da miedo subir la dosis de enalapril, ya que probablemente producirá una hiperkalemia (K+ > 5). Lo mismo pasaría si se agrega el triamterene (que produce hiperkalemia). No sirve cambiarlo por losartán ni agregarlo, ya que solo se indica para reemplazar al IECA que ha causado tos o angioedema. La C y la D son respuestas potencialmente correctas, ya que tanto agregar HCTZ, como reemplazar el IECA por HCTZ parecen razonables y la evidencia no es categórica en señalar una conducta. A pesar de eso recomendamos elegir la opción de agregar un nuevo fármacos en dosis bajas, ya que la HCTZ con los IECAs son una buena combinación y anulan sus efectos en el potasio.

Fuente: Nefrología, cuestionario 5.8, P7

109. Un paciente de 50 años, diabético tipo 2, bien controlado con metformina, acude a control, donde se le detecta hipertensión arterial, la que se confirma con varias tomas cercanas a 145/90 mmHg. ¿Qué fármaco es el más aconsejable para iniciar el tratamiento farmacológico de la hipertensión de este paciente?

a. Losartán
b. Hidralazina
c. Atenolol
d. Hidroclorotiazida
e. Amlodipino

Respuesta correcta: a. Losartán

Explicación: Tanto por ser diabético como por ser menor de 55 años de elección son los IECA, como el enalapril o, actualmente, también los ARA2, como el losartán. Si se inicia enalapril y le produce tos o angioedema (alergia), se debe cambiar a losartán. Si ambas familias de fármacos están contraindicadas, se prefieren los bloqueadores del calcio no dihidropiridínicos, como el diltiazem, ya que, al igual que los IECA y ARA2, contribuyen a disminuir la progresión del daño renal, al disminuir la proteinuria. Actualmente, la mayoría de las guías internacionales recomiendan iniciar fármacos en diabéticos con PA mayor o igual a 130/80 mmHg, a diferencia de los no diabéticos, en que el corte es 140/90 mmHg. - El atenolol sí se puede indicar en los menores de 55 años, pero está relativamente contraindicado en los diabéticos, porque

puede ocultar los síntomas iniciales de una hipoglicemia. - La HCTZ también se puede indicar en los diabéticos, puede descompensar parcialmente a la diabetes, porque aumenta la resistencia a la insulina.

Fuente: Nefrología, cuestionario 5.8, P9

110. Un paciente de 25 años es diagnosticado de hipertensión, en relación a un cuadro de cefalea y tinitus, en el que se constató PA: 210/130 mmHg. En tomas posteriores, presenta presión arterial cercana a 180/110 mmHg. Se solicitan exámenes generales, que demuestran creatininemia: 1,1 mmHg, natremia: 140 mEq/l y kalemia: 2,8 mEq/L. El diagnóstico más probable es:

a. Feocromocitoma
b. Hipertensión renovascular
c. Hipertensión esencial
d. Hipertensión secundaria a nefropatía médica
e. Síndrome nefrítico agudo

Respuesta correcta: b. Hipertensión renovascular

Explicación: Tiene una hipertensión arterial en etapa II, a los 25 años (muy joven), con crisis hipertensivas, todo lo que hace pensar en que es secundaria. La hipokalemia también sugiere una causa secundaria y, en específico: 1. HTA RV (renovascular) o 2. Hiperaldosteronismo primario (HAP), que no está en las opciones. La diferencia clínica entre HTA RV y el HAP es muy difícil, por lo que se debe estudiar con ecodoppler renal y el índice aldoslterona renina, pero hay algunos elementos que orientan a HTA RV, como la presencia de soplos renales, atrofia renal unilateral, enfermedad ateromatosa, factores de riesgo cardiovascular y edad avanzada u otras causas de estenosis arterial y, clásicamente, que la creatinina se eleva con el uso de IECA o ARA2; en cambio, orientan a HAP la hipokalemia muy severa (o síntomas de hipokalemia como calambres, debilidad muscular y la presencia de un adenoma o de hiperplasia en las suprarrenales. - En este caso, perfectamente (y probablemente) podría ser un HAP. - La HTA por nefropatía médica tendría elevación de la creatinina y tendencia a la hiperkalemia. - No tiene edema ni hematuria como para pensar en un síndrome nefrítico.

Fuente: Nefrología, cuestionario 5.8, P17

111. Un diabético tipo 2 es diagnosticado de hipertensión arterial, por lo que se decide iniciar un iECA. ¿Cuál de las siguientes es una contraindicación de este fármaco?

a. Hiperkalemia de 6,1 mEq/L
b. hemoglobina glicosilada de 8%
c. Clearence de creatinina de 60 ml/min
d. Uso concomitante de glibenclamida
e. Uso concomitante de insulina

Respuesta correcta: a. Hiperkalemia de 6,1 mEq/L

Explicación: Las contraindicaciones de los IECAs son la hiperkalemia (especialmente K+ >6 mEq/L), la estenosis de la arteria renal, elevación de la creatinina >50% después del inicio, así como la IRC con clearence menor a 30 ml/min o creatinina > 3mg/dl. También están absolutamente contraindicados en el embarazo. Finalmente, están contraindicados cuando han tenido reacciones adversas, como edema angioneurótico o tos (en estos casos se reemplazan por un ARA2; en cambio, en los demás casos también está contraindicados los ARA2). La diabetes, por el contrario es una indicación de usar ICEAS, como tratamiento antihipertensivo de elección.

Fuente: Nefrología, cuestionario 5.8, P17

Infección urinaria (6)

112. Son tratamientos adecuados para una pielonefritis, en un paciente hospitalizado, EXCEPTO:

a. Ceftriaxona
b. Cefazolina
c. Gentamicina
d. Ampicilina
e. Cefuroximo

Respuesta correcta: d. Ampicilina

Explicación: Las cefalosporinas son el tratamiento de elección de la PNA grave, aunque actualmente también se usan mucho las quinolonas endovenosas (ej. ciprofloxacino 400 mg EV c/12 o el levofloxacino 750 mg c/d). En general se indica ceftriaxona (tercera generación), ya que cubren muy bien a las enterobacterias (E. coli, Klebsiella, Proteus), pero también se pueden usar las de segunda (cefuroximo) o primera generación (cefazolina), ya que tienen buena cobertura para enterobacterias. - La gentamicina (aminoglicósido) es de elección en los pacientes alérgicos a las cefalosporinas, cuando no hay disponibilidad de quinolonas endovenosas (ej. porque son muy caras). - La ampicilina, en cambio, no cubre bien a la E. coli ni demás enterobacterias, por lo que no debe ser usada sola. La ampicilina más sulbactam sería una opción que sí tiene cierta cobertura, pero se deben preferir los medicamentos ya mencionados. - Cuando hay riesgo de pseudomona u otras bacterias resistentes (ej. paciente hospitalizado), se prefieren los carbapenémicos o, como mínimo, cefepime, ceftazidima o cefoperazona u otro esquema que las cubra.

Fuente: Nefrología, cuestionario 5.3, P16

113. ¿Cuál de los siguientes es una buena alternativa para el tratamiento ambulatorio de una pielonefritis aguda?

a. Nitrofurantoína
b. Gentamicina
c. Amoxicilina
d. Metronidazol
e. Cefadroxilo

Respuesta correcta: e. Cefadroxilo

Explicación: La PNA se trata con quinolonas orales (ciprofloxacino); o bien con cefalosporinas de primera (cefadroxilo), segunda (cefuroximo) o tercera (cefixima) generación. - La nitrofurantoína solo sirve para la ITU baja, ya que no se concentra bien a nivel renal, sino solo a nivel vesical. - La gentamicina se usa en el tratamiento hospitalizado, ya que se da solo por vía intramuscular o endovenosa. - La amoxicilina y el metronidazol no tienen buena cobertura sobre gramnegativos y por tanto, no cubren la ITU. La amoxicilina más ácido clavulánico podría tener buena cobertura, pero se prefieren otros antibióticos.

Fuente: Nefrología, cuestionario 5.4, P17

114. Una paciente de 80 años presenta malestar general, fiebre y disuria de 3 días de evolución. Hace algunas horas se agrega desorientación y sopor, por lo que acude al servicio de urgencia. Al examen físico está febril (39,5°C), con PA: 100/66 mmHg, FC: 105 x'. Se solicita sedimento de orina que muestra abundantes piocitos y leucocitos, con hematuria de 10 glóbulos rojos por campo. Su hemograma muestra leucocitosis de 17.000 por mm3 y se solicita urocultivo, cuyo resultado está pendiente. La conducta más adecuada es:

a. Hospitalizar, reanimar e iniciar ceftriaxona endovenosa
b. Hospitalizar, reanimar y solicitar exámenes de función renal, ANA, ANCA y anticuerpos antimembrana basal
c. Enviar a domicilio con cefadroxilo oral
d. Enviar a domicilio con prednisona oral
e. Enviar a domicilio con nitrofurantoína oral

Respuesta correcta: a. Hospitalizar, reanimar e iniciar ceftriaxona endovenosa

Explicación: Tiene una PNA severa, dado el compromiso de conciencia, por lo que requiere de hospitalización. El tratamiento de elección son las cefalosporinas por vía endovenosa, ya sean de primera generación (cefazolina) o, idealmente, de tercera generación (ceftriaxona o cefotaximo). También son aceptables las quinolonas endovenosas (ciprofloxacino o levofloxacino en formato endovenoso). En caso de sospecha de bacterias resistentes (ej. uso reciente de antibióticos, hospitalización previa o infección intrahospitalaria), en los casos graves es correcto indicar carbapenémicos o algún otro antibiótico de amplio espectro (ej. piperacilina más tazobactam) con cobertura para Pseudomona, Acinetobacter y demás bacterias resistentes del centro en que estuvo hospitalizada. Además, se debe reanimar con SF ev y soporte. Si hubiese estado en buenas condiciones, solo con la PNA, sería correcto el cefadroxilo oral.

Fuente: Nefrología, cuestionario 5.6, P5 · Urología, cuestionario 6.3, P11

115. Una paciente de 45 años presenta un cuadro de disuria, orinas turbias y fiebre hasta 39°C. Al examen físico está febril, en buenas condiciones, con PA: 120/80, FC: 80x' y con puño percusión positiva a derecha. Se solicita sedimento de orina que demuestra piocituria y bacteriuria y urocultivo que está pendiente. El tratamiento de elección es:

a. Nitrofurantoína oral
b. Ciprofloxacino oral
c. Metronidazol oral
d. Ceftriaxona endovenosa
e. Gentamicina endovenosa

Respuesta correcta: b. Ciprofloxacino oral

Explicación: Tiene una infección urinaria alta o pielonefritis (por la fiebre y la puño percusión). Como no está embarazada ni grave, el tratamiento de elección es con antibióticos orales, como las cefalosporinas, las quinolonas e incluso la amoxicilina más ácido clavulánico (aunque se prefieren las dos primeras). No sirve la nitrofurantoína para la ITU alta, ya que no se concentra bien a nivel renal (la nitrofurantoína sí sirve y muy bien en la ITU baja, ya que sí se concentra bien a nivel vesical).

Fuente: Nefrología, cuestionario 5.8, P7

116. Una paciente de 45 años es diagnosticada de una pielonefritis aguda, por lo que se inicia cefadroxilo oral. Usted la controla 3 días después y la paciente refiere que se sigue sintiendo mal y persiste con fiebre hasta 39,5°C. Además trae los resultados del urocultivo, que muestra desarrollo de una E. coli multisensible. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

a. Cambiar el tratamiento a ciprofloxacino oral
b. Cambiar el tratamiento a ceftriaxona endovenosa
c. Solicitar baciloscopías de orina
d. Solicitar una ecografía abdominal
e. Mantener el tratamiento y controlar en 4 días

Respuesta correcta: d. Solicitar una ecografía abdominal

Explicación: Aunque las pielonefritis generalmente se tratan con quinolonas (ciprofloxacino 500 mg c/12h o levofloxacino 750 mg/d x 7 días), las cefalosporinas orales de cualquier generación son perfectamente aceptables. La nitrofurantoína y la fosfomicina solo se usan en las ITUs bajas. La causa más frecuente de falta de respuesta a la antibioterapia en la PNA es la presencia de complicaciones, como abscesos o una obstrucción por cálculos renales. Por ello, se debe solicitar la Ecografía, que es el examen de elección para evaluar dichas complicaciones. Si se hace la ecografía y está normal y sigue sin responder, en ese caso, se indicaría ceftriaxona endovenosa (se hospitaliza por falta de respuesta al tratamiento oral). Si hubiese sido una bacteria resistente, habría sido correcto reemplazar el fármaco por otro, al que fuera sensible.

Fuente: Nefrología, cuestionario 5.8, P10

117. Una mujer presenta un cuadro de disuria y orinas turbias, sin fiebre, por lo que se solicitan exámenes de orina, que muestran un sedimento con abundantes leucocitos y bacterias y un urocultivo de segundo chorro, que está pendiente. La conducta más adecuada es:

a. Iniciar metronidazol y controlar con el urocultivo
b. Iniciar ciprofloxacino y controlar con el urocultivo
c. Iniciar amoxicilina + ácido clavulánico y controlar con el urocultivo
d. Iniciar ceftriaxona endovenosa y controlar con el urocultivo
e. Esperar al resultado del urocultivo y decidir conducta según hallazgos

Respuesta correcta: b. Iniciar ciprofloxacino y controlar con el urocultivo

Explicación: Tiene un clínica de ITU baja (ya que no hay fiebre, puño percusión ni compromiso general, como para pensar en una pielonefritis aguda). Se debe iniciar el tratamiento oral, a la espera del urocultivo (ya que demora 2 días en estar el resultado). - Si al resultado está negativo, pues se suspenden los antibióticos. Si está positivo se mantienen, si es sensible la bacteria. Si es resistente, se cambian a uno al que sí sea sensible. Hay varias opciones en una mujer adulta: 1. Quinolonolas orales (ej. Ciprofloxacino); 2. Cefalosporinas orales (ej. Cefadroxilo, cefuroximo o cefixima), 3. Nitrofurantoína (no sirve en la ITU alta, pero sí en la baja), 4. últimamente de moda en algunos países fosfomicina en monodosis (3g), 5. Cotrimoxazol forte. - Algunas recomendaciones prefieren la nitrofurantoína o la fosfomicina como primeras opciones, ya que se concentran especialmente bien en orina, pero se debe recordar que no sirven en las pielonefritis (de elección quinolonas y luego cefalosporinas, en las de tratamiento ambulatorio). - Actualmente, en una mujer joven y sana, con una clínica muy sugerente de cistitis aguda y sedimento compatible, se puede incluso prescindir del urocultivo,. - El MTZ no cubre Gram negativos, sino anaerobios y parásitos unicelulares, por lo que no sirve en las ITUs. - La amoxicilina-clavulánico sí tiene cobertura contra E. Coli, pero se usa mucho menos en las ITU, ya tiene un espectro demasiado amplio. - La ceftriaxona estaría indicada en una PNA grave, que requiera hospitalización o en una mujer embarazada

con PNA (recordar que las PNA en el embarazo preferentemente se hospitalizan) o cuando no se pueden usar las quinolonas.

Fuente: Nefrología, cuestionario 5.8, P15

Endocrinología y diabetes (132)

Hipotiroidismo, hipertiroidismo, tiroiditis y bocio (27)

1. Una paciente de 30 años presenta un bocio de tamaño moderado, difuso. No presenta síntomas y su examen físico es normal. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

a. Iniciar levotiroxina en dosis bajas
b. Solicitar TAC de cuello
c. Solicitar cintigrafía con yodo radiactivo
d. Solicitar TSH y anticuerpos anti-TPO
e. Solicitar T4 y tiroglobulina

Respuesta correcta: d. Solicitar TSH y anticuerpos anti-TPO

Explicación: El estudio inicial del bocio difuso es con TSH (es el examen más importante) y, además, puede complementarse con anticuerpos anti peroxidasa tiroidea, ya que la tiroiditis de Hashimoto es la causa más frecuente de bocio. - La ecografía se debe pedir solo en los casos en que hay un bocio nodular (como estudio del nódulo tiroideo) o en los que hay un crecimiento muy rápido, que obligue a buscar otras causas. - La cintigrafía tiroidea con yodo radiactivo solo se pide si la TSH está suprimida, es decir, si hay un hiperT4.

Fuente: Endocrinología y diabetes, cuestionario 7.1, P3

2. Una mujer de 23 años, asintomática, acude a chequeo médico, donde se le solicita una TSH que resulta 3,1 UI/L (VN: 0,4 – 4,0 UI/L) y una T4, que resulta 13,5 ug/ml (VN: 4,5 – 12,5 ug/ml). No tiene patologías conocidas, pero usa anticonceptivos orales. La conducta más adecuada es:

a. Solicitar anticuerpos anti-TPO y solicitar ecografía cervical
b. Solicitar anticuerpos TRAB y solicitar contigrafía tiroidea
c. Iniciar levotiroixina oral
d. Derivar para inicio de yodo radiactivo
e. Explicar normalidad de su situación y observar evolución

Respuesta correcta: e. Explicar normalidad de su situación y observar evolución

Explicación: Tiene TSH normal, por lo que está eutiroidea. En cambio, tiene la T4 alta, pero por usar ACO, se asume que tiene elevación de la TBG. También sería aceptable pedir T4 libre, para confirmar el estado eutiroideo, pero la verdad es que ni siquiera debió haberse pedido la T4, ya que el screening en pacientes asintomáticos se debe hacer solo con la TSH y lo principal es explicar que sus resultados son normales. Finalmente, no se debe confundir con el hipertiroidismo subclínico, en que está alterada la TSH y normal la T4 o T4 libre.

Fuente: Endocrinología y diabetes, cuestionario 7.1, P6

3. Una paciente de 34 años hipotiroidea, en tratamiento con 100 ug al día de levotiroxina, se embaraza. Usted la controla al tercer mes de embarazo y trae una TSH de 3,5 UI/L. La conducta más adecuada es:

a. Mantener indicaciones
b. Aumentar la dosis de levotiroxina
c. Solicitar T4 y T3 libres
d. Disminuir la dosis de levotiroxina
e. Reemplazar la levotiroxina por levotriyodotironina

Respuesta correcta: b. Aumentar la dosis de levotiroxina

Explicación: En el embarazo, el objetivo de la TSH es entre 0,4 y 2,5 UI/L. Por tanto, se debe subir la dosis a 125 ug/día y controlar con nueva TSH en 4 semanas (en no embarazadas se controla cada 6 semanas). Resumen actualizado de hipoT4 en embarazo: 1. El hipoT4 en el embarazo es un tema controvertido, en el que se toman algunas medidas con poca evidencia, a fin de no arriesgarse a afectar el desarrollo cerebral fetal. 2. Fisiológicamente, en el embarazo es normal que suba la T4 libre, por aumento de la TBG. También aumentan los requerimientos de T4, por lo que puede aumentar levemente la T4 libre y la TSH suele bajar a valores entre 0,2 y 2,5, aunque lo ideal es tener una tabla de valores por edad gestacional. Sin embargo, se sigue considerando como eutiroidea a valores entre 0,4 y 4,0 de TSH. 3. Las pacientes que tenían el diagnóstico previo de hipoT4 deben hacer varias cosas: - Embarazarse con valores de TSH entre 0,4 y 2,5 (previo suben un poco la dosis). - Si no la subieron antes y se embarazan, se sube la dosis en 30% aprox. - El objetivo de TSH en el embarazo es menor a 2,5. El límite bajo de la TSH varía entre 0,1 y 0,4 UI/L, según la fuente. 4. Las pacientes embarazadas sin diagnóstico previo, se deben hacer una TSH. - Si TSH > 4 y T4 libre baja = hipoT4 = tratar (dosis estándar + 30%). - Si TSH > 4 y T4 libre normal = hipoT4 subclínico = tratar con dosis menor (ej. 1 ug/Kg/día). - Si TSH entre 2,6 y 4 = discutible. Algunos tratan igual; otros solo tratan si anticuerpos antiTPO(+). - Si TSH ≤ 2,5 = sana.

Fuente: Endocrinología y diabetes, cuestionario 7.2, P1

4. Una paciente de 18 años presenta astenia, sensación de calor y diarrea, desde hace algunas semanas. Además, ha sentido molestias en los ojos. Al examen físico se constata FC: 110x', PA: 120/80, piel fina y húmeda. Se palpa un bocio difuso de tamaño moderado y se constata una ligera proptosis izquierda. El diagnóstico es:

a. Enfermedad de Basedow Graves
b. Tiroiditis de Quervein
c. Cáncer de tiroides
d. Tiroiditis de Hashimoto
e. Tiroiditis de Riedel

Respuesta correcta: a. Enfermedad de Basedow Graves

Explicación: Tiene clínica de hipertiroidismo (astenia, calor, diarrea, taquicardia, piel fina), más la clínica específica de la enfermedad de Basedow Graves (EBG), que agrega la presencia de bocio difuso y exoftalmo. El diagnóstico es clínico. - La orbitopatía no se ve en otras causas de hiperT4 (a lo más tienen retracción palpebral o signo de Graefe, que se producen por hiperadrenergia, pero no exoftalmo o proptosis, que solo en ven en la EBG). - En los casos en que queda la duda, actualmente se solicitan los anticuerpos TRAB (Thyrotropin Receptor AntiBody), que si están positivos confirman la EBG. En los casos en que no hay mucha duda, también suelen pedirse, a modo de respaldo. - Además, como parte general del estudio etiológico del hiperT4, se puede solicitar un cintingrama tiroideo con yodo radiactivo, que mostrará captación difusa (sin embargo, la mayoría de las recomendaciones solo la recomiendan en casos con TRAB negativos, justamente para buscar otras causas distintas a la EBG).

Fuente: Endocrinología y diabetes, cuestionario 7.2, P5

5. Una paciente presenta dolor en el cuello, asociado a palpitaciones y temblor. Al examen físico se aprecia aumento de volumen tiroideo, que es muy doloroso al presionarlo con los dedos. El diagnóstico más probable es:

a. Cáncer anaplásico
b. Tiroiditis aguda

c. Tiroiditis subaguda
d. Enfermedad de Basedow Graves
e. Quiste folicular roto

Respuesta correcta: c. Tiroiditis subaguda

Explicación: La tiroiditis subaguda de Quervain se caracteriza por bocio doloroso. Además, en este caso, está en la fase hipertiroidea inicial (debida a la destrucción de la tiroides se libera coloide y por tanto, T4). Se trata con AINEs y, si está muy hipertiroideo, se puede indicar betabloqueo (atenolol o propanolol). El diagnóstico es clínico, pero, en casos en que hay duda (ej. no hay dolor), se puede pedir una captación de yodo radiactivo, la que estaría disminuida. Se pueden pedir los anticuerpos anti-TPO, para definir el pronóstico: si están positivos tiene mucho mayor riesgo de evolucionar a una tiroiditis crónica de Hashimoto (en la fase inicial puede presentarse de forma muy parecida a la tiroiditis subaguda). - La tiroiditis aguda también tiene bocio doloroso, pero con signos inflamatorios claros y además se ve un paciente séptico (es una infección bacteriana, generalmente por S. aureus). - El quiste folicular es una patología ovárica, que no debe confundirse con los quistes coloideos, que son la patología tiroidea.

Fuente: Endocrinología y diabetes, cuestionario 7.2, P7

6. Un paciente de 60 años es diagnosticado de hipotiroidismo por una tiroiditis de Hashimoto por lo que se inicia tratamiento con levotiroxina 50 ug al día. Además de la evolución clínica, ¿Qué examen o exámenes es/son más adecuado(s) para controlar a este paciente?

a. Niveles plasmáticos de hormona tiroestimulante
b. Niveles plasmáticos de tiroxina
c. Niveles plasmáticos de tiroxina libre
d. Niveles plasmáticos de tiroglobulina
e. Niveles plasmáticos de anticuerpos anti-peroxidasa tiroidea

Respuesta correcta: a. Niveles plasmáticos de hormona tiroestimulante

Explicación: El tratamiento del hipotiroidismo y también del hipertiroidismo se ajustan mediante niveles de TSH, teniendo como objetivo una TSH normal, es decir, 0,4 a 4,0 UI/L, aunque algunas recomendaciones buscan como objetivo un control más acotado entre 1 y 3. Las excepciones son 1. el paciente geriátrico, en que se fija como objetivo TSH: 3 a 6 UI/L y 2. la mujer embarazada en que la TSH objetivo es 0,4 a 2,5 UI/L (algunos proponen 0,1 a 2,5). En los problemas hipofisiarios, es distinto, ya que se debe ajustar según T4 o T4 libre, puesto que la TSH se produce en la hipófisis y no variará correctamente.

Fuente: Endocrinología y diabetes, cuestionario 7.2, P12

7. ¿En qué condición es preferible solicitar T4 libre en lugar de T4 corriente?

a. Tiroiditis subaguda
b. Tiroiditis de hashimoto
c. Hipotiroidismo congénito
d. Uso de anticonceptivos orales
e. Insuficiencia cardíaca

Respuesta correcta: d. Uso de anticonceptivos orales

Explicación: Hoy en día, se suele pedir siempre T4 libre, en lugar de T4, ya que la T4 se altera con las variaciones de la TBG (globulina ligante de tiroxina), que es la proteína transportadora de la T4. Sin embargo, la T4 es un buen examen, a menos que haya una causa que haga variar los niveles de TBG. Los

ACO y el embarazo elevan la TBG. El daño hepático crónico, el síndrome nefrótico, la desnutrición proteica y el uso de anabólicos, la disminuyen. Actualmente la T4 total casi no se usa, ya que la T4 libre es barata.

Fuente: Endocrinología y diabetes, cuestionario 7.2, P18

8. Una paciente de 34 años diagnosticada de hipotiroidismo, en tratamiento con 100 ug de levotiroxina al día, desde hace 6 semanas, se realiza una TSH de control, que resulta 7,2. La conducta más adecuada es:

a. Solicitar T3 y decidir conducta según resultado
b. Solicitar T4 libre y decidir conducta según resultado
c. Mantener el tratamiento y controlar en 6 semanas más
d. Aumentar la dosis de levotiroxina
e. Disminuir la dosis de levotiroxina

Respuesta correcta: d. Aumentar la dosis de levotiroxina

Explicación: El objetivo de la TSH, en el tratamiento del hipotiroidismo, es que esté entre normal, es decir, 0,4 y 4,0 UI/L (algunos recomiendan incluso un óptimo entre 1 y 3, pero la evidencia admite el rango normal completo). Por tanto, al estar elevada, sigue hipotiroidea y se debe subir la dosis. - En el embarazo, el objetivo es de 0,4 a 2,5 (algunos proponen 0,1 a 2,5). En adultos mayores, el objetivo es 3 a 6. En pacientes con T4 normal (hipoT4 subclínico), se tolera sin tratamiento hasta 10, pero, una vez iniciado el tratamiento, se busca el mismo objetivo que la población general.

Fuente: Endocrinología y diabetes, cuestionario 7.3, P2

9. Un paciente de 65 años se realiza pruebas de función tiroidea, como parte de un chequeo médico, presentado los siguientes valores: TSH: 9,1 UI/L (VN: 0,4 – 4,0), T4 libre: 0,3 ng/dl (VN: 0,7 – 1,9), T3 libre: 0,4 pg/ml (VN: 0,8 – 4,1). La conducta más adecuada es:

a. Solicitar anticuerpos anti-TPO y decidir conducta según resultados
b. Solicitar perfil lipídico y decidir conducta según resultados
c. Observar evolución y controlar con nuevos exámenes en 3 meses
d. Iniciar levotiroxina (T4)
e. Iniciar triyodotironina (T3)

Respuesta correcta: d. Iniciar levotiroxina (T4)

Explicación: Tiene un hipotiroidismo, dado que la TSH está elevada y la T4 libre está baja. El hipotiroidismo se trata con levoT4. No es un hipotiroidismo subclínico, ya que, por definición, el hipotiroidismo subclínico tiene T4 libre normal. Si así hubiese sido, sería correcto la C (observar), puesto que el hipoT4 subclínico solo se trata en casos seleccionados (TSH mayor a 10, embarazo y alteraciones atribuibles al hipoT4).

Fuente: Endocrinología y diabetes, cuestionario 7.3, P5

10. La asociación entre temblor, fiebre, taquicardia y dolor cervical, es sugerente de:

a. Cáncer diferenciado de tiroides
b. Cáncer anaplásico de tiroides
c. Quiste del conducto tirogloso
d. Enfermedad de Basedow graves
e. Tiroiditis de Quervain

Respuesta correcta: e. Tiroiditis de Quervain

Explicación: La tiroiditis subaguda se caracteriza por bocio doloroso e inicialmente puede tener síntomas hipertiroideos. - El cáncer se presenta como nódulo tiroideo indoloro. - El quiste tirogloso suele presentarse en la infancia o adolescencia como un nódulo cervical, ubicado en la línea media, que se moviliza con la deglución.

Fuente: Endocrinología y diabetes, cuestionario 7.3, P11

11. ¿Cuál de los siguientes casos clínicos es más sugerente de una enfermedad de Basedow-Graves?

a. Mujer de 40 años con bocio difuso y exoftalmo, asociado a intolerancia al calor, nerviosismo y temblor

b. Mujer de 65 años con bocio difuso de consistencia pétrea, asociado a astenia y elevación de la TSH

c. Mujer de 40 años con bocio difuso, muy doloroso a la palpación, con temblor y disminución de la TSH

d. Mujer de 30 años con bocio multinodular de gran tamaño, asociado a retracción palpebral, elevación de la T4 y disminución marcada de la TSH

e. Mujer de 40 años con mixedema generalizado, bocio difuso y astenia

Respuesta correcta: a. Mujer de 40 años con bocio difuso y exoftalmo, asociado a intolerancia al calor, nerviosismo y temblor

Explicación: La enfermedad de Basedow Graves se caracteriza por hipertiroidismo, más un bocio difuso, que puede tener soplo tiroideo, mixedema pretibial y exoftalmo o proptosis / exoftalmo (la orbitopatía es propia de la EBG y no de otras causas de hiperT4; en cambio la retracción palpebral y el signo de Graefe se puede ver en cualquier causa de hiperT4). - La B puede ser una tiroiditis de Riedel con hipotiroidismo. - La C es una tiroiditis subaguda de Quervain. - La D es un bocio multinodular tóxico. - La E es un hipotiroidismo, probablemente por enfermedad de Hashimoto.

Fuente: Endocrinología y diabetes, cuestionario 7.4, P1

12. Un paciente de 70 años, que vive solo, es encontrado inconsciente en su casa. Al examen físico presenta FC: 45 x', PA: 110/70 mmHg, t°: 34,0°C, facies edematosa y sopor profundo. No presenta focalidad neurológica, pero sus reflejos osteotendíneos están abolidos. En sus exámenes destaca anemia con hematocrito de 30%, plaquetas: 250.000, blancos: 5.000 por mm3, creatinina: 1,0 mg/dl, sodio: 130 mEq/L, potasio: 4,5 mEq/L y cloro: 98 mEq/L. El diagnóstico más probable es:

a. Síndrome de secreción inadecuada de ADH

b. Diabetes insípida

c. Insuficiencia suprarrenal

d. Enfermedad de Cushing

e. Hipotiroidismo

Respuesta correcta: e. Hipotiroidismo

Explicación: Tiene un coma mixedematoso, que es la manifestación más grave del hipotiroidismo. Apoyan el diagnóstico: bradicardia, hipotermia, arreflexia, anemia (suele ser macrocítica), hiponatremia y edema (mixedema). Se trata con levotiroxina endovenosa (idealmente más triyodotironina), aunque, si no está disponible, se puede dar por sonda nasogástrica. Además, es fundamental administrar corticoides endovenosos, hasta descartar que exista una insuficiencia suprarrenal asociada. Resumen: T4 + T3 + hidrocortisona ev.

Fuente: Endocrinología y diabetes, cuestionario 7.4, P2

13. Una paciente de 50 años consulta por aumento de volumen de la glándula tiroides. Al examen físico se palpa un bocio difuso de tamaño moderado. Se solicita TSH que resulta 8,4 UI/L. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

a. Tiroiditis de Hashimoto
b. Tiroiditis de Quervain
c. Tiroiditis de Riedel
d. Enfermedad de Basedow Graves
e. Cáncer de tiroides

Respuesta correcta: a. Tiroiditis de Hashimoto

Explicación: La asociación de bocio difuso e hipotiroidismo es clásica de la tiroiditis crónica de Hashimoto, que además es la causa más frecuente, tanto de bocio, como de hipotiroidismo.` * En este caso, se debe pedir la T4 libre (y repetir la TSH) para diferenciar si es un HipoT4 propiamente tal (que requiere levotiroxina) o solo un hipoT4 subclínico (que se puede observar). Será correcto también pedir anticuerpos anti-TPO, para objetivar la tiroiditis de Hashimoto. - La tiroiditis de Quervain tiene un bocio doloroso, con hipertiroidismo. - La tiroiditis de Riedel tiene un bocio leñoso, difuso, habitualmente eutoroideo, aunque puede ser hipotiroideo. - La EBG tiene un bocio difuso con hipertiroidismo. - El cáncer se presenta como bocio nodular.

Fuente: Endocrinología y diabetes, cuestionario 7.4, P6

14. Un paciente de 60 años se realiza una TSH como screening, la que resulta 7,5 UI/L. Está asintomático, su examen físico es normal y no presenta otras patologías conocidas. La conducta más adecuada es:

a. Solicitar T4 libre y decidir conducta según resultado
b. Solicitar T3 libre y decidir conducta según resultado
c. Observar evolución, sin necesidad de tratamiento, ni control
d. Iniciar levotiroxina
e. Solicitar cintigrafía con yodo radiactivo

Respuesta correcta: a. Solicitar T4 libre y decidir conducta según resultado

Explicación: Si la TSH está elevada, se sospecha un hipotiroidismo, sin embargo, primero se debe confirmar con T4 libre, puesto que, si está normal, tendría un hipotiroidismo subclínico, que suele observarse si la TSH está bajo 10. En cambio, si está baja la T4, se trataría de un hipotiroidismo clínico o hipotiroidismo propiamente tal y se debe iniciar el tratamiento con levoT4. En la práctica, también se debe repetir la TSH, junto con pedir la T4 libre. Se pueden pedir anticuerpos anti-TPO. No está indicado solicitar T3, TRH, tiroglobulina ni otros exámenes.

Fuente: Endocrinología y diabetes, cuestionario 7.4, P12

15. Una paciente de 34 años es diagnosticada de hipotiroidismo mediante niveles plasmáticos de TSH y T4. Se inicia tratamiento con levotiroxina 100 ug/día. ¿Cómo y cuándo debe controlarse?

a. En 2 semanas con niveles plasmáticos de T4
b. En 2 semanas con niveles plasmáticos de TSH
c. En 6 semanas con niveles plasmáticos de T4 libre
d. En 6 semanas con niveles plasmáticos de TSH
e. En 3 meses con niveles plasmáticos de T4 libre

Respuesta correcta: d. En 6 semanas con niveles plasmáticos de TSH

Explicación: Los síntomas suelen empezar a mejorar luego de 2 semanas de tratamiento, pero la TSH demora 6 semanas en estabilizarse. El tratamiento del hipotiroidismo se controla con niveles de TSH cada 6 semanas (4 a 6 semanas es aceptable), hasta normalizar la TSH y luego, cada 3 meses. Si se logra un control estable y prolongado, se puede luego espaciar incluso cada 6 a 12 meses (antes, si hay cualquier síntoma).

Fuente: Endocrinología y diabetes, cuestionario 7.5, P1

16. Una paciente de 18 años presenta astenia, constipación, ánimo bajo y somnolencia, por lo que se realiza exámenes generales (hemograma y perfil bioquímico) que muestran cierto grado de anemia e hipercolesterolemia. Además, se palpa un bocio difuso de tamaño moderado y se constata macroglosia. El diagnóstico es:

a. Enfermedad de Basedow Graves
b. Tiroiditis de Quervein
c. Cáncer de tiroides
d. Tiroiditis de Hashimoto
e. Tiroiditis de Riedel

Respuesta correcta: d. Tiroiditis de Hashimoto

Explicación: Tiene probablemente un hipotiroidismo por todos sus síntomas y por la aparición de anemia y dislipidemia (suele producir anemia macrocítica, elevación del colesterol LDL e hiponatremia). Que tenga bocio difuso, sugiere mucho una tiroiditis de Hashimoto, que es la causa más frecuente de bocio y de hipertiroidismo. La tiroiditis de Quervain tiene un bocio doloroso, con hipertiroidismo. La tiroiditis de Riedel tiene un bocio leñoso, difuso, habitualmente eutoroideo, aunque puede ser hipotiroideo. La EBG tiene un bocio difuso con hipertiroidismo. El cáncer se presenta como bocio nodular.

Fuente: Endocrinología y diabetes, cuestionario 7.5, P5

17. Una paciente consulta por otalgia, por lo que se realiza otoscopía, que resulta normal. Al examen físico se aprecia bocio moderado, doloroso a la palpación. Se solicita una TSH que resulta disminuida y una T4, que resulta elevada. El tratamiento más adecuado para la patología descrita es:

a. Quirúrgico
b. Levotiroxina
c. Prednisona
d. Ibuprofeno
e. Propiltiouracilo

Respuesta correcta: d. Ibuprofeno

Explicación: El diagnóstico es una tiroiditis subaguda de Quervain, que se trata con AINEs. Si tiene muchos síntomas hipertiroideos (como en este caso), se puede agregar propanolol o atenolol, pero no drogas antitiroideas (propiltiouracilo o metimazol). En los casos que no responden, se puede agregar prednisona al tratamiento con AINEs. En la fase hipotiroidea, no suele ser necesario tratar, ya que son síntomas transitorios y leves.

Fuente: Endocrinología y diabetes, cuestionario 7.5, P7

18. La asociación de bocio difuso, con soplo y síntomas de hipertiroidismo es característica de:

a. Adenoma tóxico
b. Tiroiditis de Quervain

c. Tiroiditis de Riedel
d. Enfermedad de Basedow Graves
e. Tiroiditis de Hashimoto

Respuesta correcta: d. Enfermedad de Basedow Graves

Explicación: La EBG se caracteriza por hipertiroidismo asociado a bocio difuso, que puede tener soplo tiroideo. El adenoma tóxico tiene bocio nodular, sin soplo. La Tiroiditis de Quervain sí tiene bocio difuso e hipertiroidismo, pero no soplo. Además, el bocio es doloroso. La tiroiditis de Riedel y la de Hashimoto no hacen hipertiroidismo, sino hipotiroidismo.

Fuente: Endocrinología y diabetes, cuestionario 7.5, P12

19. Un paciente consulta por palpitaciones y diarrea. Al examen físico se constata retracción palpebral, temblor fino, piel húmeda y caliente, sin alteraciones a la palpación de la glándula tiroides. Se solicita TSH que resulta suprimida y T4 que está aumentada. Los anticuerpos anti-TPO y TRAB resultan negativos, la tiroglobulina plasmática es indetectable y la captación de yodo radiactivo muestra captación menor al 1%. El diagnóstico más probable es:

a. Tiroiditis de Riedel
b. Tiroiditis silente
c. Tiroiditis de Quervain
d. Struma Ovari
e. Uso de tiroxina exógena

Respuesta correcta: e. Uso de tiroxina exógena

Explicación: Es una pregunta algo difícil. Tiene un hipertiroidismo, tanto por la clínica, como por la TSH suprimida con T4 elevada. La captación de yodo muy baja sugiere una tiroiditis subaguda de Quervain, pero esta tendría elevación de la tiroglobulina (Tg). Por tanto, la sospecha es el consumo exógeno, que es la única opción con Tg disminuida. El struma ovari es un tumor ovárico, que produce hipertiroidismo.

Fuente: Endocrinología y diabetes, cuestionario 7.5, P17

20. ¿En qué condición es preferible solicitar T4 libre en lugar de T4 corriente?

a. Tiroiditis subaguda
b. Tiroiditis de Hashimoto
c. Hipotiroidismo congénito
d. Embarazo
e. Insuficiencia cardíaca

Respuesta correcta: d. Embarazo

Explicación: Hoy en día, se suele pedir siempre T4 libre, en lugar de T4, ya que la T4 se altera con las variaciones de la TBG (globulina ligante de tiroxina), que es la proteína transportadora de la T4. Sin embargo, la T4 es un buen examen, a menos que haya una causa que haga variar los niveles de TBG. Los ACO y el embarazo elevan la TBG. El daño hepático crónico, el síndrome nefrótico, la desnutrición proteica y el uso de andrógenos, los disminuyen.

Fuente: Endocrinología y diabetes, cuestionario 7.5, P18

21. Un paciente de 60 años, cirrótico por consumo de alcohol, se realiza pruebas tiroideas como parte de un chequeo médico, que muestran TSH: 1,8 UI/L (VN: 0,4- 4,0) y T4: 4,0 ug/dl (VN: 4,5 – 12,5 ug/dl). El diagnóstico más probable es:

a. Eutiroideo
b. Hipotiroidismo subclínico
c. Tiroiditis de Hashimoto
d. Cáncer de tiroides
e. Hepatocarcinoma

Respuesta correcta: a. Eutiroideo

Explicación: Tiene TSH normal, por lo que está eutiroideo. La T4 está baja probablemente por la baja en la TBG, secundaria al daño hepático crónico. La T4 libre probablemente estará normal. Además, incluso en casos en que la T4 libre está baja, pero la TSH normal (ej. eutiroideo enfermo), no es necesario tratar. En resumen, si el paciente no tiene síntomas, solo se debe pedir la TSH y no la T4 o T4 libre ni mucho menos la T3 o T3 libre.

Fuente: Endocrinología y diabetes, cuestionario 7.6, P1

22. Un paciente es diagnosticado de hipotiroidismo por una tiroiditis crónica, por lo que se inicia suplementación hormonal con levotiroxina. ¿Qué examen es el más adecuado para seguir la evolución de este paciente?

a. Hormona tiroestimulante
b. Tiroxina
c. Anticuerpos antiperoxidasa tiroidea
d. Triyodotironina
e. Tiroglobulina

Respuesta correcta: a. Hormona tiroestimulante

Explicación: El tratamiento del hipotiroidismo se ajusta según los niveles de TSH, los que se busca normalizar. Se solicita cada 4-6 semanas, hasta lograr una TSH normal. Luego se sigue cada 3 meses, hasta que la TSH se mantiene estable. Finalmente, se puede espaciar cada 6 a 12 meses, una vez lograda la estabilidad en el largo plazo.

Fuente: Endocrinología y diabetes, cuestionario 7.6, P4

23. ¿Cuál de las siguientes opciones es más sugerente de una tiroiditis aguda bacteriana?

a. Bocio difuso, asociado a exoftalmo y síntomas de hipertiroidismo
b. Bocio difuso asociado a síntomas de hipotiroidismo
c. Bocio multinodular con síntomas de hipertiroidismo
d. Bocio, asociado a intenso localizado en el lóbulo tiroideo izquierdo y fiebre alta
e. Bocio difuso, doloroso, asociado a síntomas leves de hipertiroidismo

Respuesta correcta: d. Bocio, asociado a intenso localizado en el lóbulo tiroideo izquierdo y fiebre alta

Explicación: La tiroiditis aguda suele tener un inicio súbito y asociarse a fiebre y mucho dolor en la tiroides. Aunque puede afectar toda la tiroides, lo más frecuente es que se presente en un solo lóbulo. Los signos inflamatorios suelen ser muy marcados. Los pacientes habitualmente están eutiroideos, aunque puede haber hipertiroidismo. El diagnóstico es clínico y se suele complementar con ecografía y punción aspiración para cultivo. Generalmente se produce por Gram positivos, (S. aureus y S. pyogenes), aunque

puede ser por otras bacterias. Se debe iniciar tratamiento urgente con antibióticos endovenosos y, si hay un absceso (clínico o ecográfico), actualmente se prefiere drenar por punción. Solo en los casos en que no responde, se resuelve con drenaje quirúrgico o resección del área infectada. En niños, suele asociarse a un tipo especial de fístula branquial, llamada "fístula del receso piriforme", que produce infecciones recurrentes generalmente del lóbulo tiroideo izquierdo. - La A es una enfermedad de Basedow Graves. - La B es una tiroiditis de Hashimoto. - La C es un bocio multinodular tóxico. - La E es una tiroiditis subaguda de Quervain.

Fuente: Endocrinología y diabetes, cuestionario 7.6, P10

24. Un paciente de 60 años asintomático se realiza exámenes de control, que muestran hemograma normal, perfil lipídico normal, TSH: 5,0 UI/L y T4 8,0 ug/ml (VN: 4,5 – 12,5 ug/ml). Su examen físico es normal. La conducta más adecuada es:

a. Observar evolución
b. Iniciar levotiroxina oral
c. Solicitar cintigrafía tiroidea
d. Realizar ecografía cervical
e. Solicitar anticuerpos TRAB

Respuesta correcta: a. Observar evolución

Explicación: Tiene un hipotiroidismo subclínico (TSH alta, con T4 normal). Como no tiene dislipidemia, ni otras alteraciones, no es necesario tratarlo y basto con observar evolución. Si la TSH hubiese estado mayor a 10 o hubiese comorbilidad (depresión, dislipidemia, demencia), sí estaría indicada la levotiroxina. También en el embarazo, ya que existe temor ante una eventual riesgo teórico de afectación del desarrollo cerebral fetal (discutible).

Fuente: Endocrinología y diabetes, cuestionario 7.7, P1

25. ¿Cuál es el primer examen que debe solicitarse a un paciente con bocio difuso?

a. Anticuerpos anti-TPO y TRAB
b. Ecografía cervical
c. TSH
d. Cintigrafía con yodo radiactivo
e. Tiroglobulina

Respuesta correcta: c. TSH

Explicación: Lo más importante en el estudio del bocio difuso es la función tiroidea. Por tanto, la TSH es el examen más importante. Además, se puede complementar con los anticuerpos, en especial los anti-TPO (marcadores de la tiroiditis de Hashimoto, que es la causa más frecuente de bocio). De las opciones, la TSH es la más adecuada. La ecografía se solicita en el bocio nodular y en el bocio de rápido crecimiento (y aun en estos casos la TSH es fundamental).

Fuente: Endocrinología y diabetes, cuestionario 7.7, P6

26. Un paciente de 24 años presenta un cuadro de odinofagia y tos, que dura 4 días y luego mejora. Sin embargo, una semana después, inicia dolor cervical, asociado a malestar general y fatiga. El dolor aumenta con los movimientos del cuello y al examen físico se constata aumento de volumen, muy doloroso a la palpación, en relación a la zona supraesternal del cuello, en la línea media. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

a. Solicitar ecografía de cuello

b. Iniciar naproxeno y solicitar pruebas tiroideas
c. Solicitar TAC de cuello
d. Iniciar prednisona
e. Iniciar amoxicilina más ácido clavulánico

Respuesta correcta: b. Iniciar naproxeno y solicitar pruebas tiroideas

Explicación: El diagnóstico de sospecha es una tiroiditis subaguda (incluso tiene la infección viral previa, que suele describirse por los pacientes). Su diagnóstico es fundamentalmente clínico, pero se suele complementar el estudio con pruebas tiroides (que suelen mostrar elevación de la T4, T3, tiroglobulina y disminución de la TSH y captación de yodo), hemograma y PCR, con frecuente elevación de los parámetros inflamatorios. El tratamiento es con AINEs y, solo en casos en que no responde o que hay síntomas sistémicos muy intensos (ej. mucha fiebre y mialgias), se puede indicar prednisona. En la primera fase, la hipertiroidea, no hay hiperproducción de T4, sino liberación, por lo que no están indicadas las drogas antitiroideas, sino solo el propanolol o atenolol (betabloqueo)en caso de que tenga muchos síntomas hipertiroideos. En la segunda fase, la hipotiroidea, no se requiere suplementar, ya que suele ser breve y poco sintomática. En la última fase, la eutiroidea, todo normaliza. Si, en cambio, evoluciona a un hipotiroidismo, pudo haber sido una enfermedad de Hashimoto inicial (la presencia de anticuerpos anti-TPO aumenta el riesgo de progresar de esta forma).

Fuente: Endocrinología y diabetes, cuestionario 7.8, P1

27. El hipotiroidismo suele presentar la siguiente alteración en el perfil lipídico:

a. Colesterol LDL aumentado
b. Colesterol HDL aumentado
c. Colesterol HDL bajo
d. Triglicéridos aumentados
e. Colesterol LDL pequeño y denso

Respuesta correcta: a. Colesterol LDL aumentado

Explicación: El hipoT4 se asocia a LDL aumentado. En cambio, la diabetes se asocia a HDL bajo, TG aumentados y LDL pequeño y denso (que es más aterogénico que el LDL común y corriente).

Fuente: Endocrinología y diabetes, prueba 1 (captura), P4

Nódulo tiroideo y cáncer de tiroides (9)

28. Un paciente de 40 años presenta aumento de volumen cervical. Al examen físico se palpa un nódulo de 2 cm de diámetro, en relación a la glándula tiroides, que asciende con la deglución. Se solicita una ecografía cervical, que lo visualiza de aspecto sólido-quístico, sin adenopatías y una TSH que resulta 1,0 UI/L. La conducta más adecuada es:

a. Resolver quirúrgicamente de inmediato
b. Solicitar TAC de cuello
c. Realizar punción aspiración con aguja fina
d. Solicitar cintigrafía con yodo radiactivo
e. Solicitar niveles plasmáticos de calcitonina y tiroglobulina

Respuesta correcta: c. Realizar punción aspiración con aguja fina

Explicación: El orden de estudio del nódulo tiroideo es 1. TSH y ecografía cervical y 2. Punción con aguja fina (PAAF). - De acuerdo a la guía Minsal, se punciona si es mayor a 10 mm; aunque si es quístico, se

puede esperar a que tenga 15 mm. - Vale la pena mencionar que en guías internacionales se recomienda estratificar el nódulo de acuerdo a su aspecto ecográfico, desde TR1 hasta TR5 (clasificación de Tirrads, muy similar a la de Birrads en el nódulo mamario) y definir con ello la necesidad de PAAF. TR1: tiroides normal. No hay nódulo que puncionar. TR2: benigno. Ejemplo clásico: quiste simple sin pared. No requiere puncionar, independientemente del tamaño. TR3: probablemente benigno. Puncionar sobre 15 mm. TR4: probablemente maligno. Puncionar sobre 10 mm. TR5: maligno. Puncionar independientemente del tamaño (aunque bajo 5 mm puede ser muy difícil y ello se le debe advertir al paciente). La cintigrafía solo se pide si es que hay hipertiroidismo asociado, de modo de diferenciar si es un nódulo caliente o hipercaptante (causante del hiperT4 y que requiere tratamiento con yodo radiactivo: I131 o cirugía) o si, en cambio, es un nódulo "frío", normocaptante o hipocaptante, que se punciona con aguja fina, para saber qué es.

Fuente: Endocrinología y diabetes, cuestionario 7.1, P2

29. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es FALSA respecto al cáncer papilar de tiroides?

a. Es el cáncer de tiroides más frecuente
b. Se disemina por vía linfática
c. Su tratamiento es la tiroidectomía total
d. Se beneficia del uso de yodo radiactivo
e. Una vez tratado, debe seguirse periódicamente con triyodotironina plasmática, para detectar precozmente las recidivas

Respuesta correcta: e. Una vez tratado, debe seguirse periódicamente con triyodotironina plasmática, para detectar precozmente las recidivas

Explicación: El cáncer papilar es el más frecuente (85% de los casos), seguido del cáncer folicular. Ambos se tratan con tiroidectomía total más yodo radiactivo y se siguen luego con tiroglobulina: Tg (no con triyodotironina: T3). El papilar se disemina por vía linfática; el folicular, por vía hematógena.

Fuente: Endocrinología y diabetes, cuestionario 7.1, P4

30. ¿Qué patología se asocia al cáncer medular de tiroides y debe ser descartada antes de tratarlo?

a. Hipoparatiroidismo
b. Feocromocitoma
c. Enfermedad de Addison
d. Enfermedad de Cushing
e. Acromegalia

Respuesta correcta: b. Feocromocitoma

Explicación: El cáncer medular de tiroides se asocia a la NEM tipo 2 (Neoplasia endocrina múltiple tipo 2), la que además es causa de hiperparatiroidismo primario y feocromocitoma. Además, el feocromocitoma siempre debe diagnosticarse antes de una cirugía (solicitando metanefrinas y catecolaminas urinarias de 24 horas y, si están elevadas, solicitando RMN o TAC de suprarrenales; si no lo encuentran, se puede pedir un PET-scan), ya que puede descompensar al paciente durante la anestesia y debe ser tratado antes con alfabloqueantes (fenoxibenzamina), betabloqueantes (propanolol) y cirugía (en ese orden: A, B y C).

Fuente: Endocrinología y diabetes, cuestionario 7.2, P4

31. Un paciente de 35 años presenta un nódulo tiroideo, que se moviliza con la deglución. Se solicita una TSH, que resulta 4,0 UI/L y una ecografía cervical, que lo demuestra de aspecto sólido-quístico y de 2 cm x 1 cm de diámetro. La conducta más adecuada es:

a. Iniciar levotiroxina
b. Solicitar tiroglobulina
c. Solicitar calcitonina
d. Solicitar biopsia por punción con aguja fina
e. Solicitar cintigrafía con yodo radiactivo

Respuesta correcta: d. Solicitar biopsia por punción con aguja fina

Explicación: El orden de estudio del nódulo tiroideo es 1. TSH y ecografía cervical y 2. Punción con aguja fina (PAAF). - De acuerdo a la guía Minsal, se punciona si es mayor a 10 mm; aunque si es quístico, se puede esperar a que tenga 15 mm. - Vale la pena mencionar que en guías internacionales se recomienda estratificar el nódulo de acuerdo a su aspecto ecográfico, desde TR1 hasta TR5 (clasificación de Tirrads, muy similar a la de Birrads en el nódulo mamario) y definir con ello la necesidad de PAAF. En este caso, por ser sólido-quístico parece un TR3 o TR4. TR1: tiroides normal. No hay nódulo que puncionar. TR2: benigno. Ejemplo clásico: quiste simple sin pared. No requiere puncionar, independientemente del tamaño. TR3: probablemente benigno. Puncionar sobre 15 mm. TR4: probablemente maligno. Puncionar sobre 10 mm. TR5: maligno. Puncionar independientemente del tamaño (aunque bajo 5 mm puede ser muy difícil y ello se le debe advertir al paciente). La cintigrafía solo se pide si es que hay hipertiroidismo asociado, de modo de diferenciar si es un nódulo caliente o hipercaptante (causante del hiperT4 y que requiere tratamiento con yodo radiactivo: I131 o cirugía) o si, en cambio, es un nódulo "frío", normocaptante o hipocaptante, que se punciona con aguja fina, para saber qué es.

Fuente: Endocrinología y diabetes, cuestionario 7.2, P8

32. Un paciente de 34 años consulta por aumento de volumen cervical. Al examen físico se palpa un nódulo tiroideo de 2 cm de diámetro, duro, que asciende con la deglución. Se Solicita una ecografía que lo visualiza de aspecto sólido, sin adenopatías cervicales asociadas. Se realiza una punción aspirativa con aguja fina, obteniéndose una citología compatible con un carcinoma folicular (lesión folicular con displasias de alto grado). La conducta más adecuada es:

a. Iniciar tratamiento con yodo radiactivo
b. Realizar tiroidectomía total y seguir con niveles plasmáticos de calcitonina
c. Realizar tiroidectomía total, con linfadenectomía cervical
d. Realizar tiroidectomía total y en segunda instancia tratar con yodo radiactivo
e. Realizar tiroidectomía parcial e iniciar levotiroxina en dosis altas

Respuesta correcta: d. Realizar tiroidectomía total y en segunda instancia tratar con yodo radiactivo

Explicación: El cáncer folicular (y también el papilar) se manejan con tiroidectomía total, más tratamiento con yodo radiactivo, en segunda instancia y levotiroxina (tanto para suprimir la TSH como para evitar el hipoT4 secundario a la tiroidectomía; se busca una TSH más baja que en otras causas de hipoT4). La linfadenectomía solo se indica si es que hay ganglios cervicales palpables o ecográficos. Se sigue con tiroglobulina (también se pide una preoperatoria). - En cambio, el cáncer medular, se trata con tiroidectomía, más linfadenectomía y luego quimioterapia y/o radioterapia, según el estadío (no sirve el yodo radiactivo). Se sigue con calcitonina y antígeno carcinoembrionario (también se piden prequirúrgicos). Antes de la cirugía se debe 1. descartar feocromocitoma (metanefrinas urinarias) y 2. realizar estudio de NEM (neoplasias endocrinas múltiples, con el gen RET, por ejemplo).

Fuente: Endocrinología y diabetes, cuestionario 7.3, P7 · Cirugía, cuestionario 8.2, P22

33. Un paciente de 40 años consulta por aumento de volumen cervical, el que detectó hace cerca de un mes. Al examen físico se palpa un nódulo cervical de consistencia dura, ubicado en la línea media anterior, en la zona supraesternal, que asciende con la deglución, de cerca de 2 cm de diámetro. Se solicita TSH, la que resulta 3,8 UI/L. La conducta más adecuada es:

a. Solicitar anticuerpos anti-TPO
b. Solicitar ecografía cervical
c. Solicitar TAC de cuello
d. Solicitar niveles plasmáticos de tiroglobulina
e. Solicitar niveles plasmáticos de calcitonina

Respuesta correcta: b. Solicitar ecografía cervical

Explicación: El nódulo tiroideo y los nódulos cervicales en general, se estudian inicialmente con ecografía de cuello (antes se solicita TSH eso sí). Luego, se procede a la biopsia por punción con aguja fina, si es mayor a 1 cm (Minsal) o, de acuerdo al aspecto ecográfico Tirrads: - TR1: no hay nódulo. - TR2: quiste simple = observar. - T3 y T4: PAAF si > 10-15 mm. - T5: PAAF siempre (difícil si <5 mm). La excepción es el nódulo con TSH baja (hipertiroideo), en que se pide la cintigrafía. Si es hipercaptante (caliente), se trata con I131 o cirugía. Si es hipocaptante o normocaptante (frío), se punciona, de acuerdo a lo ya explicado, para saber qué es.

Fuente: Endocrinología y diabetes, cuestionario 7.4, P3

34. ¿Qué marcador es más útil para el seguimiento de un cáncer folicular de tiroides, luego de haber completado exitosamente el tratamiento, de modo de detectar precozmente una recidiva?

a. Niveles plasmáticos de calcitonina
b. Niveles plasmáticos de triyodotironina
c. Niveles plasmáticos de tiroglobulina
d. Niveles plasmáticos de tiroxina
e. Cintigrafía con yodo radiactivo

Respuesta correcta: c. Niveles plasmáticos de tiroglobulina

Explicación: Recordar que el cáncer diferenciado de tiroides (papilar y folicular) se trata con cirugía (generalmente tiroidectomía total, salvo casos de muy bajo riesgo que se pueden tratan con hemitiroidectomía) y luego se puede dar yodo radiactivo como terapia adyuvante (se ajusta la dosis con una cintigrafía posoperatoria y, en casos de bajo riesgo, puede no darse). Tanto el cáncer folicular, como el papilar se siguen con tiroglobulina (Tg). Si se eleva, se presume que hay una recidiva, ya que la tiroides fue extirpada y exógenamente está recibiendo T4, pero no se produce tiroglobulina (proteína precursora, que contiene las tirosinas [un tipo de aminoácido] que se modifican para generar la tiroxina). Por tanto, si se eleva, ahí sí se pide la cintigrafía con yodo radiactivo, para localizar la recidiva. También se suele controlar con ecografía cervical, para ver las recidivas locales. * Resumen: Cáncer diferenciado = Qx +/- yodo radiactivo + seguimiento con Tg y ecografía. - El cáncer medular, en cambio, se sigue con calcitonina.

Fuente: Endocrinología y diabetes, cuestionario 7.5, P4

35. Un paciente de 35 años presenta un nódulo tiroideo, que es puncionado con una aguja fina, demostrándose la presencia de un cáncer papilar de tiroides. La conducta más adecuada, en este momento, es:

a. Iniciar levotiroxina

b. Iniciar tratamiento con yodo radiactivo
c. Iniciar tratamiento con propiltiouracilo
d. Resolver mediante tiroidectomía total
e. Solicitar cintigrafía con yodo radiactivo

Respuesta correcta: d. Resolver mediante tiroidectomía total

Explicación: El tratamiento del cáncer papilar y folicular de tiroides es con tiroidectomía total, Luego se hace una cintigrafía con yodo radiactivo, de modo de determinar la dosis de yodo radiactivo que se dará postcirugía. Después de todo, queda con levotiroxina, dado que se le extirpó la tiroides (como cultura general, tiene doble efecto: 1. tratar el hipotiroidismo post tiroidectomía y 2. suprimir la TSH para evitar que estimule a cualquier tumor remanente; de hecho, suele quedar con un objetivo de TSH muy bajo, entre 0,1 y 0,5 y, en los casos de mucho riesgo, incluso TSH menor a 0,1 UI/L).

Fuente: Endocrinología y diabetes, cuestionario 7.5, P8

36. Una paciente de 50 años, asintomático, se detecta un aumento de volumen cervical, ubicado en la línea media. Al examen físico se aprecia un nódulo supraesternal de 2 cm de diámetro, que asciende con la deglución. Se solicita una ecografía que demuestra un nódulo sólidoquístico de 21 mm de diámetro. La TSH resulta 6,3 UI/L. La conducta más adecuada es:

a. Realizar punción con aguja fina del nódulo
b. Administrar yodo radiactivo en dosis terapéutica
c. Solicitar cintigrafía con yodo radiactivo
d. Realizar tiroidectomía total
e. Indicar una dosis baja de levotiroxina y observar evolución

Respuesta correcta: a. Realizar punción con aguja fina del nódulo

Explicación: El nódulo tiroideo se estudia con TSH, ecografía y luego punción con aguja fina (si es mayor a 10 mm o 15 mm, según la fuente que se revise). Solo cuando la TSH está suprimida (menor a 0,4 = hipertiroidismo), se estudia con la cintigrafía, para descartar el adenoma tóxico. En cambio, en este caso, la TSH está alta, por lo que el nódulo se debe estudiar de la manera habitual, además de manejarse el hipotiroidismo. Los quistes simples, Tirrads 2, se pueden observar, independiente del tamaño, según las guías internacionales.

Fuente: Endocrinología y diabetes, cuestionario 7.5, P13

Patología suprarrenal (20)

37. Una paciente de 30 años consulta por un cuadro de marcado malestar general y ortostatismo. Al examen físico está sudorosa, con FC: 110x' y PA: 90/60 mmHg, que no aumenta, luego de administrar un litro de suero fisiológico. Se aprecia hiperpigmentación de las manos y la mucosa oral y su hemoglucotest es de 63 mg/dl. La conducta más adecuada es:

a. Solicitar cortisol libre urinario de 24 horas
b. Solicitar metanefrinas urinarias
c. Administrar levotiroxina oral
d. Administrar corticoides endovenosos
e. Solicitar resonancia magnética nuclear de silla turca

Respuesta correcta: d. Administrar corticoides endovenosos

Explicación: La sospecha clínica es una insuficiencia suprarrenal aguda (crisis suprarrenal), dado la hipotensión refractaria, asociada a la hiperpigmentación (lo que sugiere enfermedad de Addison: insuficiencia suprarrenal primaria). Además, la glicemia en el límite bajo, la sugiere. Ante la mera sospecha, ya se deben indicar los corticoides. También sería correcto tomar una muestra de sangre, antes de administrar la hidrocortisona, de modo de medir cortisol en plasma. Durante la crisis adrenal, lo fundamental es tratar y el estudio se puede diferir, pero está bien solicitar cortisol basal, ya que si está demasiado bajo (<80 nmol/L), se confirma el diagnóstico, incluso sin el test de estimulación con ACTH, que es el de elección para el diagnóstico de insuficiencia suprarrenal. * En los casos crónicos, se mide el cortisol basal: - Si <80 nmol/L = insuficiencia suprarrenal. - SI >500 = se descarta la insuficiencia suprarrenal. - Si 80-500 = test de ACTH hace la diferencia (si logra que suba el cortisol sobre 500, descarta. Si no, confirma). * Los niveles de ACTH y aldosterona diferencian las causas primarias de las hipofisiarias: - Primaria: ACTH alta y aldosterona baja. - Hipofisiaria / hipotalámica: ACTH baja y aldosterona normal.

Fuente: Endocrinología y diabetes, cuestionario 7.1, P8

38. Un paciente presenta un cuadro de 3 meses de evolución de astenia, asociado a disminución de las masas musculares, con obesidad de predominio central. Al examen físico se aprecian estrías abdominales, “cara de luna” y tungo. Se solicita una prueba de supresión corta, que resulta alterada, por lo que se realiza una prueba de supresión larga, la que no suprime y se piden niveles de ACTH, que resultan indetectables. ¿Qué examen es más adecuado para proseguir el estudio en este paciente?

a. Resonancia magnética nuclear de silla turca
b. Metanefrinas en orina
c. TAC de abdomen
d. Niveles plasmáticos de cortisol y DHEAs
e. Radiografía de tórax

Respuesta correcta: c. TAC de abdomen

Explicación: El diagnóstico es un síndrome de Cushing, en el que ya fue confirmado el hipercortisolismo con la prueba de supresión corta. Además, es de localización suprarrenal, puesto que la ACTH está indetectable y la prueba de supresión larga no suprime. Por tanto, se debe proseguir el estudio con un TAC de suprarrenales, para ver si hay un tumor productor de cortisol o una hiperplasia. Si la ACTH estuviese elevada y la prueba de supresión larga suprimiera, la respuesta correcta sería la RMN de silla turca, ya que se sospecharía un tumor hipofisiario productor de ACTH. ** Recordatorio de estudio de sospecha de síndrome de Cushing (pacientes con clínica compatible, osteoporosis secundaria o HTA secundaria, adenoma adrenal): Solicitar cualquiera de los siguientes test (si mucha sospecha, se puede pedir más de uno): 1. Cortisol libre urinario de 24 horas. 2. Cortisol en saliva (noche). 3. Cortisol basal y post-dexametasona (1 mg) = "supresión corta". - Si están alterados dos de ellos o muy alterado uno, se confirma el hipercortisolismo y se sigue el estudio para buscar la causa, con niveles de ACTH: 1. Si ACTH muy baja (<5 pg/ml): causa es suprarrenal. Se sigue estudio con TAC o RMN de suprarrenales. 2. Si ACTH muy elevada (>20 pg/ml): causa es hipofisiaria (ACTH dependiente: Enfermedad de Cushing). Se sigue estudiando con RMN de hipófisis. 3. Si ACTH indeterminada (5-20 pg/ml): solicitar test de supresión larga. Si suprime, es hipofisiario. Si no suprime, es suprarrenal.

Fuente: Endocrinología y diabetes, cuestionario 7.1, P9

39. Una paciente de 30 años consulta por malestar general y síncopes, por hipotensión ortostática. Al examen físico está muy decaída, con FC: 130x', regular, PA: 70/30 mmHg, mucosas con hiperpigmentación de lengua y cara interna de las mejillas. Se solicitan exámenes, que muestran hiponatremia, hiperkalemia y glicemia de 60 mg/dl. La conducta más adecuada es:

a. Administrar suero fisiológico e iniciar noradrenalina endovenosa
b. Administrar alfabloqueantes y luego betabloqueantes
c. Solicitar test de supresión con dexametasona
d. Administrar suero fisiológico e hidrocortisona por vía endovenosa
e. Administrar suero fisiológico y solicitar resonancia magnética de silla turca

Respuesta correcta: d. Administrar suero fisiológico e hidrocortisona por vía endovenosa

Explicación: La sospecha clínica es una insuficiencia suprarrenal aguda (crisis suprarrenal), dada la hiperpigmentación (lo que sugiere enfermedad de Addison: insuficiencia suprarrenal primaria). Además, la glicemia en el límite bajo, la hiponatremia y la hiperkalemia, la sugieren fuertemente. Ante la mera sospecha, ya se deben indicar los corticoides endovenosos (hidrocortisona), más el suero fisiológico. También se solicita cortisol basal (si está bajo confirma). En agudo, se prefiere tratar, incluso sin un diagnóstico claro. En agudo no se puede hacer la prueba de estimulación con ACTH, porque la hidrocortisona altera la medición del cortisol plasmático.

Fuente: Endocrinología y diabetes, cuestionario 7.2, P3

40. Un paciente de 60 años presenta astenia y debilidad muscular. Al examen físico se aprecia atrofia de la musculatura de las 4 extremidades, asociado a estrías abdominales y “cara de luna”. Además, se solicitan exámenes generales, entre los que destaca glicemia de ayuno de 180 mg/dl. La conducta más adecuada es:

a. Solicitar cortisol libre urinario de 24 horas
b. Solicitar niveles plasmáticos de ACTH
c. Solicitar test de tolerancia a la glucosa
d. Solicitar radiografía de tórax
e. Administrar cortisol

Respuesta correcta: a. Solicitar cortisol libre urinario de 24 horas

Explicación: Tiene un síndrome de Cushing. El síntoma más frecuente es la astenia y el signo más frecuente es la atrofia muscular, pero lo característico son la obesidad central y las estrías violáceas. El cortisol es una hormona de contrarregulación, por lo que hay una diabetes secundaria. El examen de elección para iniciar el diagnóstico puede variar y, dentro de las opciones están: 1. el cortisol libre urinario de 24 horas, 2. el cortisol salival nocturno y 3. la prueba de supresión corta con dexametasona (prueba de Nuggent). - De segunda línea, para identificar la causa del hipercortisolismo, se pide la TSH (si alta, es hipofisiaria; si TSH baja es adrenal) y, si queda la duda, se pide la prueba de supresión larga o prueba de Liddle (si suprime, es hipofisiaria; si no suprime, es suprarrenal). - De tercera línea se pide la RMN de hipófisis (si se sospecha que es hipofisiaria), o bien la RMN o TAC de suprarrenales (si se sospecha que es adrenal).

Fuente: Endocrinología y diabetes, cuestionario 7.2, P6

41. Un paciente de 26 años, con hipertensión arterial, se realiza exámenes generales, en los que destaca hipokalemia, por lo que se solicita índice de aldosterona/ARP, el que resulta 60 (VN: menor a 25). El tratamiento de la patología descrita es:

a. Cirugía vascular de arterias renales
b. Inhibidores de la enzima convertidora de angiotensiana
c. Tiazidas
d. Propanolol
e. Espironolactona

Respuesta correcta: e. Espironolactona

Explicación: El diagnóstico es un hiperaldosteronismo primario (HAP), ya que el índice aldosterona renina está mayor a 20-30 (ese es el punto de corte más aceptado la sospecha, aunque con el varlor que tiene, está prácticamente confirmado. Algunos autores proponen que, ante la duda, se debe confirmar con una prueba de supresión de aldosterona con sodio: tras la administración de sal, debería bajar la aldosterona. Sin embargo, en la práctica se suele ir directamente a una imagen de las suprarrenales, en busca de un tumor o hiperplasia. - El tratamiento habitual consiste en inhibidores del receptor de aldosterona (espironolactona de elección o eplerenona, si la espironolactona produce efectos adversos). El tratamiento médico en de elección en la hiperplasia suprarrenal bilateral. En el caso de que haya una causa unilateral clara (ej. tumor suprarrenal productor de aldosterona), se prefiere la resolución quirúrgica (idealmente adrenalectomía unilateral laparoscópica).

Fuente: Endocrinología y diabetes, cuestionario 7.2, P15

42. Una paciente de 50 años consulta por un cuadro de astenia y debilidad de 3 semanas de evolución. Refiere además náuseas y cambios en la coloración de las manos. Al examen físico se aprecia hiperpigmentación de las manos y la mucosa oral. El examen más adecuado para confirmar la sospecha diagnóstica es:

a. Resonancia magnética de silla turca
b. Cortisol libre urinario de 24 horas
c. ACTH plasmática
d. Prueba de supresión con dexametasona
e. Prueba de estimulación con ACTH

Respuesta correcta: e. Prueba de estimulación con ACTH

Explicación: Se sospecha una enfermedad de Addison, que se estudia con la prueba de estimulación con ACTH. Eso sí, si el cortisol basal es muy bajo, se confirma de inmediato y no es necesario proceder a la estimulación con ACTH. El tratamiento consiste en suplementar cortisol (con cortisol oral) y aldosterona (con fludrocortisona). Si tiene una patología descompensante, se sube la dosis. Si tienen una crisis adrenal, basta la sospecha, para dar corticoides endovenosos, además del manejo del shock.

Fuente: Endocrinología y diabetes, cuestionario 7.3, P1

43. Una paciente de 50 años presenta una hipertensión arterial de difícil manejo, que inició hace cerca de un mes y que ha presentado varias crisis hipertensivas, a pesar de estar en tratamiento con enalapril e hidroclorotiazida en dosis máximas. Además, refiere crisis de pánico y en su examen físico destaca FC: 130 latidos por minuto y PA: 170/110 mmHg. Su electrocardiograma muestra una taquicardia sinusal. El diagnóstico de sospecha es:

a. Hipertiroidismo

b. Feocromocitoma
c. Hiperaldosteronismo primario
d. Tiroiditis subaguda
e. Síndrome de secreción ectópica de ACTH

Respuesta correcta: b. Feocromocitoma

Explicación: Tiene una HTA probablemente secundaria, dado que es refractaria a tratamiento. Que haga crisis hipertensivas y de pánico, asociado a la taquicardia, hacen sospechar un feocromocitoma, ya que la principal característica de sus síntomas es que son paroxísticos. - El hipertiroidismo sí puede tener crisis de pánico y taquicardia, pero le sobra la hipertensión severa y las crisis hipertensivas. - El hiperaldosteronismo primario produce hipertensión, pero no los demás síntomas, sino hipokalemia, con debilidad.

Fuente: Endocrinología y diabetes, cuestionario 7.3, P9

44. La causa más frecuente de insuficiencia suprarrenal en Chile es actualmente:

a. Autoinmune
b. Tuberculosis
c. Postquirúrgica
d. Congénita
e. Viral

Respuesta correcta: a. Autoinmune

Explicación: La causa más frecuente actualmente es la adrenalitis autoinmune. En segundo lugar, está la tuberculosis suprarrenal (que también se pregunta en el Eunacom).

Fuente: Endocrinología y diabetes, cuestionario 7.3, P10

45. Un paciente presenta un síndrome de Cushing. No utiliza ningún medicamento ni tiene antecedentes médicos de importancia. La conducta más adecuada es:

a. Solicitar niveles plasmáticos de ACTH
b. Solicitar cortisol plasmático basal
c. Solicitar prueba de supresión corta con dexametasona
d. Solicitar prueba de estimulación con ADH
e. Solicitar ACTH urinaria

Respuesta correcta: c. Solicitar prueba de supresión corta con dexametasona

Explicación: El examen clásico para iniciar el estudio del síndrome de Cushing es el cortisol libre de 24 horas y aún sigue siendo una prueba correcta. Sin embargo, como alternativas, igualmente buenas, está la prueba de supresión corta con dexametasona (o test de Nuggent, que mide cortisol basal y post-administración de una baja dosis de dexametasona: 1mg) o el cortisol salival nocturno. Después de confirmar el hipercortisolismo, se suele proseguir con niveles de ACTH más la prueba de supresión larga. Ambas solo sirven para identificar el sitio de secreción (si ACTH baja y no suprime: causa suprarrenal; si ACTH alta y suprime: causa hipofisiaria). Luego se prosigue con una imagen suprarrenal o hipofisiaria, según los resultados anteriores. - El cortisol basal es un examen demasiado errático. - La prueba de estimulación con ACTH es pata el diagnóstico del Addison.

Fuente: Endocrinología y diabetes, cuestionario 7.4, P5

46. Una paciente lúpica, suspende sus medicamentos de manera brusca, evolucionando con marcado malestar, náuseas y ortostatismo. Al examen físico presenta taquicardia e hipotensión arterial. En la atención de urgencia, esta paciente debe recibir

a. Corticoides endovenosos y suero fisiológico
b. Suero glucosado endovenoso
c. Desmopresina en spray nasal
d. Insulina endovenosa
e. Suero hipertónico endovenoso

Respuesta correcta: a. Corticoides endovenosos y suero fisiológico

Explicación: La sospecha es una insuficiencia suprarrenal aguda, secundaria a la suspensión brusca del tratamiento con corticoides (en este caso por el lupus). Ante la simple sospecha, ya se deben administrar corticoides endovenosos, más cristaloides (suero).

Fuente: Endocrinología y diabetes, cuestionario 7.4, P8

47. Una paciente de 30 años consulta por malestar general y astenia. Al examen físico se aprecian algunas melanoplaquias en la cavidad oral. Se solicitan exámenes generales, en los que destaca hiperkalemia de 5,5 mEq/L. La conducta más adecuada es:

a. Solicitar TAC de silla turca
b. Solicitar TAC abdominal
c. Solicitar cortisol basal y post dexametasona
d. Solicitar cortisol basal y post ACTH
e. Solicitar cortisol libre en orina, de 24 horas

Respuesta correcta: d. Solicitar cortisol basal y post ACTH

Explicación: Se sospecha una enfermedad de Addison (causa más frecuente de insuficiencia suprarrenal), la que se confirma con la prueba de estimulación con ACTH, que es cortisol basal y post-ACTH. - Eso sí, si el cortisol basal está muy bajo (<80 nmol/L), se confirma el diagnóstico de inmediato. - Si está muy elevado (>500 nmol/L, se descarta). - Entre 80 y 500, aplica se administra la ACTH y se vuelve a medir. Si sube sobre 500 se descarta; si no sube, se confirma la insuficiencia suprarrenal. (no es necesario saber los puntos de corte). * Los demás exámenes de las alternativas son parte del estudio del síndrome de Cushing (que es lo contrario).

Fuente: Endocrinología y diabetes, cuestionario 7.5, P3

48. ¿Cuál de las siguientes alteraciones en MENOS probable de ser hallada en un paciente con enfermedad de Cushing?

a. Elevación de la ACTH
b. Elevación de la glicemia de ayuno
c. Hipotensión arterial
d. Atrofia muscular
e. Mayor susceptibilidad a contraer infecciones

Respuesta correcta: c. Hipotensión arterial

Explicación: La enfermedad de Cushing es causada por un tumor hipofisiario, productor de ACTH y es la causa más frecuente de síndrome de Cushing. Eleva la ACTH. El cortisol es una hormona de contrarregulación de la insulina, por lo que puede producir una diabetes o descompensarla.

Generalmente produce hipertensión, porque el exceso de ACTH termina por estimular a la aldosterona, produciéndose retención de agua y sodio. Suele cursar con atrofia muscular (es el signo más frecuente en el examen físico). Los corticoides producen inmunodepresión. De hecho los pacientes con esta enfermedad suelen fallecer por infecciones.

Fuente: Endocrinología y diabetes, cuestionario 7.5, P6

49. Un niño diagnosticado de hiperplasia suprarrenal congénita, en tratamiento, presenta un cuadro de malestar general marcado e hipotensión. Al examen se constata desorientado, taquicárdico, con signos de hipoperfusión periférica. La conducta más adecuada es:

a. Administrar suero fisiológico endovenoso hasta normalizar la
b. Administrar corticoides endovenosos y cristaloides
c. Administrar suero hipertónico endovenoso
d. Administrar cristaloides y noradrenalina endovenosa por bomba de infusión continua
e. Administrar suero glucosado al 30% y adrenalina subcutánea

Respuesta correcta: b. Administrar corticoides endovenosos y cristaloides

Explicación: La HSRC es causa de insuficiencia suprarrenal e hiperandrogenismo, por un defecto genético en las enzimas productoras de cortisol. En este caso, se sospecha una crisis suprarrenal o insuficiencia suprarrenal aguda (dada la hipotensión, más el antecedente de HSRC), por lo que se debe administrar de inmediato los corticoides y el suero fisiológico.

Fuente: Endocrinología y diabetes, cuestionario 7.5, P20

50. Una paciente de 50 años presenta un cuadro de astenia y malestar general, de 4 semanas de evolución, asociado a náuseas. Al examen físico se aprecian algunas máculas hiperpigmentadas en las manos y la cara. En sus exámenes generales destaca hiponatremia y potasio de 5,5 mEq/L. La conducta diagnóstica más adecuada es:

a. Solicitar ACTH y cortisol basales
b. Solicitar ACTH y MSH
c. Solicitar RMN de silla turca
d. Solicitar cortisol basal y post-dexametasona
e. Solicitar cortisol basal y post-ACTH

Respuesta correcta: e. Solicitar cortisol basal y post-ACTH

Explicación: Se sopecha una enfermedad de Addison: hiperpigmentación más insuficiencia suprarrenal (hiperkalemia, hiponatremia, astenia y náuseas). Se onfirma con la prueba de estimulación con ACTH, que es costisol basal y post-ACTH. Si el cortisol basal es muy bajo, se confirma sin necesidad de estimular con ACTH.

Fuente: Endocrinología y diabetes, cuestionario 7.6, P2

51. Un paciente de 40 años consulta por astenia y aumento de peso. Al examen físico se aprecia atrofia de las masas musculares de las extremidades, con obesidad central, tungo y cara de luna. Además, presenta presión arterial 150/90 mmHg y glicemia basal de 150 mg/dl. Se solicita cortisol libre urinario de 24 horas, que resulta elevado. Adicionalmente, se solicita prueba de supresión larga que muestra una supresión parcial y niveles plasmáticos de ACTH que resultan elevados. El diagnóstico más probable es:

a. Síndrome de Cushing por corticoides exógenos
b. Tumor productor de ACTH

c. Enfermedad de Addison
d. Hiperplasia suprarrenal
e. Tumor adrenal productor de cortisol

Respuesta correcta: b. Tumor productor de ACTH

Explicación: Tiene un síndrome de Cushing confirmado, con el cortisol libre urinario elevado. Al estudiar la causa, orienta a una causa hipofisiaria, ya que tiene ACTH elevada y la prueba de supresión larga suprimió. Por tanto, lo más probable es que sea una enfermedad de Cushing, o tumor hipofisiario productor de ACTH. La A (corticoides exógenos), D (hiperplasia) y E (tumor adrenal) tendrían ACTH baja y no suprimiría con la dexametasona. La C (Addison) sí eleva la ACTH, pero es una insuficiencia suprarrenal, es decir, todo lo contrario.

Fuente: Endocrinología y diabetes, cuestionario 7.6, P8

52. Un niño de 3 meses de vida, con mal incremento ponderal, presenta deterioro del hipotenso. En su examen físico se aprecia escroto hiperpigmentado. En sus exámenes se constata hiponatremia e hiperkalemia. El diagnóstico más probable es:

a. Enfermedad de Addison
b. Enfermedad de Cushing
c. Hiperplasia suprarrenal congénita
d. Hipotiroidismo congénito
e. Agenesia hipofisiaria

Respuesta correcta: c. Hiperplasia suprarrenal congénita

Explicación: El cuadro clínico es compatible con una insuficiencia suprarrenal: hipotensión, hiperkalemia, hiponatremia. Además, la hiperpigmentación sugiere que es una insuficiencia de tipo primaria. Por ser un niño, la sospecha es una hiperplasia suprarrenal congénita. Pero si hubiese sido un adulto, sería una enfermedad de Addison. Se debe estudiar con 17-OH progesterona. También es correcto solicitar niveles de cortisol e imágenes suprarrenales. - En muchos países se solicita 17-OH-progesterona a todos los recién nacidos, como forma de screening. - En los países en que no se realiza, se suele presentar como insuficiencia suprarrenal o virilización (niña con megaclítoris o niño con aumento de tamaño peneano y desarrollo o hiperpigmentación testicular). - En los casos atípicos, suele presentarse tardíamente, con una clínica idéntica al síndrome de ovario poliquístico (SOP), por lo que algunos recomiendan estudiar todo SOP con 17-OH-progesterona.

Fuente: Endocrinología y diabetes, cuestionario 7.7, P3

53. La causa más frecuente de la insuficiencia suprarrenal en lactantes es:

a. Genética
b. Infecciosa
c. Neoplásica
d. Iatrogénica
e. Autoinmune

Respuesta correcta: a. Genética

Explicación: En niños, la causa más frecuente de insuficiencia suprarrenal es la hiperplasia suprarrenal congénita que es una enfermedad genética, autosómica recesiva, caracterizada, en la gran mayoría de los casos, por la deficiencia de la enzima 21 hidroxilasa, que se traduce en la imposibilidad de convertir la 17-OH progesterona (la que se acumula) en cortisol y aldosterona. Por ello hace una insuficiencia suprarrenal

perdedora de sal. En adultos, la causa más frecuente es la adrenalitis autoinmune, seguido de la tuberculosis suprarrenal.

Fuente: Endocrinología y diabetes, cuestionario 7.7, P5

54. ¿Cuál de las siguientes alteraciones es MENOS sugerente de una enfermedad de Addison?

a. Hiperglicemia
b. Hiponatremia
c. Hipercalcemia
d. Eosinofilia
e. Hiperkalemia

Respuesta correcta: a. Hiperglicemia

Explicación: La enfermedad de Addison o insuficiencia suprarrenal primaria se caracteriza por hiperkalemia, hoponatremia e hipoglicemia (ya que el cortisol suele elevar la glicemia y en esta enfermedad está deficiente). Además pude cursar con hipercalcemia, leucocitosis, linfocitosis y eosinofilia.

Fuente: Endocrinología y diabetes, cuestionario 7.7, P8

55. Un paciente de 6 años ha sido hospitalizado en 3 oportunidades por diarrea y malestar general, con requerimientos de hidratación endovenosa. Acude al servicio de urgencia por un cuadro de dolor abdominal intenso y deterioro del estado general, siendo evaluado y diagnosticado de apendicitis aguda, por lo que se llama al cirujano infantil. Al examen físico está hipotenso y desorientado. Se administran 2 bolos de suero fisiológico, sin respuesta y se inicia manejo con drogas vasoactivas, con respuesta parcial. En sus exámenes destaca leucocitosis: 12.000 por mm/3, sodio: 128 mEq/L, potasio: 5,9 mEq/L, creatinina: 1,8 mg/dl, proteína C reactiva: 40 mg/L. ¿Qué indicación es la más urgente, además de la resolución quirúrgica?

a. Noradrenalina endovenosa
b. Gluconato de calcio
c. Ceftriaxona más metronidazol
d. Hidrocortisona
e. Adrenalina intramuscular

Respuesta correcta: d. Hidrocortisona

Explicación: La sospecha es una insuficiencia suprarrenal aguda severa, por lo que se debe manejar con hidrocortisona ante la sola sospecha. Orienta a ella la hiperkalemia, hiponatremia y shock refractario. Por la edad, puede ser una hiperplasia suprarrenal congénita o una enfermedad de Addison. Es más frecuente de lo que se piensa y los médicos generales deben saber identificarla y tratarla, ya que la vida del paciente depende de ello. Si bien la insuficiencia suprarrenal puede producir dolor abdominal, sí es posible que tenga una apendicitis y que esta patología aguda sea, precisamente, lo que descompensa al paciente.

Fuente: Endocrinología y diabetes, cuestionario 7.8, P2

56. Una paciente de 35 años es diagnosticada de diabetes mellitus hace 6 meses, con difícil control metabólico, a pesar de tener una buena adherencia a tratamiento. El día de hoy sufre una caída a nivel, resultando con una fractura de muñeca, cuya radiografía muestra, además, signos de osteoporosis. Al examen físico se aprecian signos de fractura de muñeca derecha y, además, FC: 70x', PA: 150/100 mmHg, IMC: 36 y con atrofia muscular de cuádriceps, brazos y antebrazos. ¿Qué examen es el más adecuado para iniciar el estudio?

a. FSH, LH, progesterona y estradiol plasmáticos
b. Cortisol salival nocturno y cortisol en orina de 24 horas
c. Resonancia magnética nuclear de silla turca
d. Calcio y PTH plasmática
e. Péptido C e insulina plasmática

Respuesta correcta: b. Cortisol salival nocturno y cortisol en orina de 24 horas

Explicación: La sospecha es un síndrome de Cushing, con muchos signos sugerentes (obesidad, atrofia muscular, hipertensión, obesidad, diabetes y osteoporosis). Los exámenes iniciales son cualquiera de los 3 siguientes: 1. Cortisol libre urinario de 24 horas, 2. Cortisol en saliva, tomado en la noche o 3. Test de supresión corto con dexametasona (Test de Nuggent). En caso de que haya mucha sospecha, las guías internacionales recomiendan pedir 2 de los test mencionados. En caso de estar alterados, se prosigue con el estudio de la causa (test de supresión larga, ACTH, TAC o RMN de hipófisis o suprarrenales, según sea el caso).

Fuente: Endocrinología y diabetes, cuestionario 7.8, P6

Patología hipofisiaria (14)

57. Una paciente de 50 años consulta por astenia y dificultad para ver de un mes de evolución, que ha ido en aumento. Al examen físico presenta aumento de tamaño de las manos y pies, la nariz y los labios. Además, se aprecia un defecto campimétrico, compatible con una hemianopsia heterónima bitemporal. En sus exámenes generales destaca glicemia de ayuno de 180 mg/dl. ¿Cuál de es el diagnóstico más probable?

a. Tumor hipofisiario productor de TSH
b. Síndrome de compresión del tallo hipofisiario
c. Tumor hipofisiario productor de GH
d. Neoplasia endocrina múltiple tipo 2
e. Síndrome poliglandular

Respuesta correcta: c. Tumor hipofisiario productor de GH

Explicación: La hemianopsia bitemporal sugiere lesión del quiasma óptico, que habitualmente es secundaria a un tumor hipofisiario. Además tiene clínica de acromegalia: aumento de tamaño de las manos, pies, nariz, labios, orejas y la diabetes secundaria (dado que la GH es una hormona de contrarregulación de la insulina). La acromegalia se diagnostica con IGF-1 (insulin like growth factor 1 = factor de crecimiento símil a insulina 1), también llamada somatomedina 1. Si está elevada, se pide la RMN de hipófisis, aunque en este caso está igualmente indicada la RMN por la hemianopsia bitemporal.

Fuente: Endocrinología y diabetes, cuestionario 7.1, P10

58. Paciente de 56 años es traído al servicio de urgencias por cefalea intensa, vómitos y visión doble que se iniciaron hace 40 minutos. Al examen destaca estrabismo divergente y hemianopsia heterónima bitemporal. El diagnóstico más probable es:

a. Apoplejía hipofisiaria
b. Síndrome de Sheehan
c. Síndrome de sección del tallo hipofisiario
d. Síndrome de silla turca vacía
e. Síndrome de compresión de tallo hipofisiario

Respuesta correcta: a. Apoplejía hipofisiaria

Explicación: Es una apoplejía hipofisiaria clásica: cefalea súbita, con hemianopsia bitemporal (compromiso de quiasma) y suele evolucionar con un síndrome de hipertensión endocraneana (HTEC). Se produce por infarto o hemorragia de un tumor hipofisiario. El diagnóstico es clínico (cefalea súbita "thunderclap", con hemianopsia bitemporal, afectación de otros pares craneanos, HTEC), aunque se puede objetivar con una neuroimagen (RMN o TAC). El tratamiento consiste en la descompresión quirúrgica transesfenoidal, más analgesia, sin olvidarse de la suplementación hormonal, en especial de cortisol en el momento agudo, ya que cursa con un hipopituitarismo súbito, que luego suele cronificar. - El síndrome de Sheehan es un hipopituitarismo, secundario a un infarto de la hipófisis, debido a una hemorragia postparto. En la TAC se puede ver como una silla turca vacía (no hay hipófisis: otra causa es el TEC). - La sección y compresión del tallo hipofisiario producen un hipopituitarismo, con prolactina elevada.

Fuente: Endocrinología y diabetes, cuestionario 7.2, P11

59. En una paciente con síndrome de Sheehan, la prueba de progesterona y la prueba de estrógeno + progesterona, serán respectivamente:

a. Positiva y positiva
b. Positiva y negativa
c. Negativa y positiva
d. Negativa y negativa
e. Positiva y no interpretable

Respuesta correcta: c. Negativa y positiva

Explicación: El síndrome de Sheehan es un infarto hipofisiario, por lo que produce un hipogonadismo hipogonadotrópico. - La prueba de progesterona solo está positiva en la anovulación y está negativa en las otras causas, incluyendo el hipogonadismo. - La prueba de estrógeno más progesterona está positiva en el hipogonadismo (tanto ovárico: con FSH alta, como hipotálamo-hipofisiario: con FSH baja) y negativa en los problemas útero-genitales (ej. en las sinequias uterinas o síndrome de Asherman). * En todo caso, actualmente se usan mucho menos estas pruebas, ya que han sido reemplazadas por la medición de distintos niveles hormonales.

Fuente: Endocrinología y diabetes, cuestionario 7.2, P13

60. La hiperprolactinemia en hombres se manifiesta frecuentemente como:

a. Ginecomastia aislada
b. Galactorrea aislada
c. Impotencia sexual y disminución de la libido
d. Astenia y vómitos
e. Ginecomastia y galactorrea

Respuesta correcta: c. Impotencia sexual y disminución de la libido

Explicación: La hiperprolactinemia en hombres habitualmente no produce ginecomastia (es causada por los estrógenos), ni galactorrea (requiere que la mama esté estrogenizada), sino que simplemente genera un hipogonadismo de tipo hipogonadotrópico (ya que afecta al eje hipotálamo-hipófisis). Por tanto, su clínica será la astenia y problemas sexuales clásicos del hipogonadismo. Solo una mínima fracción tendrá galactorrea.

Fuente: Endocrinología y diabetes, cuestionario 7.2, P19

61. Un paciente de 70 años, sin antecedentes de importancia, presenta impotencia sexual y disminución de la libido. Además, refiere astenia. Al preguntarle dirigidamente, refiere pérdida de las erecciones matinales. Al examen físico presenta disminución del vello corporal, sin otros hallazgos. La conducta más adecuada es:

a. Solicitar niveles plasmáticos de prolactina, testosterona, FSH y LH
b. Solicitar niveles plasmáticos de testosterona, dihidroepiandrosterona e inhibina
c. Solicitar niveles plasmáticos de SHBG y DHEAs
d. Solicitar niveles plasmáticos de FSH, LH y 17-OH-Progesterona
e. Solicitar cariograma

Respuesta correcta: a. Solicitar niveles plasmáticos de prolactina, testosterona, FSH y LH

Explicación: Tiene clínica de hipogonadismo, por lo que se debe estudiar con las hormonas sexuales, gonadotropinas y prolactina. El cariograma sirve para algunas causas de hipogonadismo, en específico, para el síndrome de Klinefelter, pero se habría sospechado mucho antes de los 70 años.

Fuente: Endocrinología y diabetes, cuestionario 7.3, P6

62. Un paciente de 35 años, sin enfermedades crónicas conocidas, se realiza un TAC de cerebro, por estudio de un traumatismo encéfalo-craneano, el que no visualiza fracturas ni hemorragias, sin embargo, demuestra la presencia de un tumor hipofisiario de 8 mm de diámetro. Su TSH, prolactina, cortisol basal y niveles de testosterona son normales. La conducta más adecuada es:

a. Observar evolución
b. Iniciar bromocriptina
c. Resolver quirúrgicamente
d. Solicitar niveles plasmáticos de ACTH, CRH y GnRH
e. Solicitar test de la sed

Respuesta correcta: a. Observar evolución

Explicación: La causa más frecuente de tumores hipofisiarios son los adenomas no funcionantes, que suelen encontrarse como hallazgos en las neuroimágenes, solicitadas por otras causas (como en este caso). Si son asintomáticos y no son hiperproductores de hormonas (por eso se solicitaron la prolactina y demás), simplemente se observan. Si son sintomáticos o hiperproductores, se operan (excepto los prolactinomas, que se tratan con agonistas dopaminérgicos: ej. bromocriptina, a menos que no respondan, caso en el que se manejan con cirugía transesfenoidal).

Fuente: Endocrinología y diabetes, cuestionario 7.3, P12

63. pregunta13: Una mujer, sin antecedentes de importancia, presenta amenorrea desde hace 5 meses, asociado a galactorrea, a pesar de contar con una prueba de embarazo negativa. La conducta más adecuada para iniciar el estudio es:

a. Prueba de estrógeno + progesterona
b. Prueba de progesterona
c. Niveles plasmáticos de LH y FSH
d. Niveles plasmáticos de prolactina
e. Niveles plasmáticos de progesterona y estradiol

Respuesta correcta: d. Niveles plasmáticos de prolactina

Explicación: El síndrome amenorrea-galactorrea es la forma más frecuente de presentación de la hiperprolactinemia en mujeres, por lo que es lo primero a descartarse en este caso. Sin embargo, es muy importante dejar claro que lo primero siempre es descartar embarazo. En los casos en que es muy improbable un embarazo (ej. buen uso de ACO) o reglas regulares sin atraso, lo correcto es pedir prolactina, aunque, por consideraciones medico legales, se debe pedir simultáneamente la subunidad beta HCG, para descartar embarazo igual.

Fuente: Endocrinología y diabetes, cuestionario 7.3, P13

64. ¿Cuál de las siguientes es una alteración más probable en un paciente con un macroadenoma no funcionante de hipófisis?

a. Amaurosis
b. Miosis
c. Estrabismo convergente
d. Hemianopsia homónima
e. Hemianopsia heterónima bitemporal

Respuesta correcta: e. Hemianopsia heterónima bitemporal

Explicación: Los tumores hipofisiarios suelen comprimir el quiasma óptico, lo que se traduce en lesiones bitemporales del campo visual (ya sea hemianopsia o cuadrantopsia bitemporal). La amaurosis se ve en la lesión del nervio óptico. La miosis es por lesión del sistema simpático (ej. síndrome de Horner). La hemianopsia homónima se debe a lesiones de cintilla óptica, radiación óptica o lóbulo occipital contralateral.

Fuente: Endocrinología y diabetes, cuestionario 7.4, P10

65. Una paciente de 50 años presenta astenia, asociada a amenorrea de 5 meses de evolución, por lo que acude al policlínico. Al examen físico se constata que presenta una cuadrantopsia bitemporal inferior. El diagnóstico más probable es:

a. Lesión hipotalámica
b. Tumor hipofisiario
c. Climaterio
d. Síndrome poliglandular
e. Apoplejía hipofisiaria

Respuesta correcta: b. Tumor hipofisiario

Explicación: La amenorrea puede ser producida por todas las patologías de las alternativas. Sin embargo, la afectación bitemporal del campo visual es característica de la compresión del quiasma óptico por un

tumor hipofisiario. No tiene cefalea aguda, ni hipertensión endocraneana, como para sospechar una apoplejía, por lo que es un tumor que ha ido creciendo.

Fuente: Endocrinología y diabetes, cuestionario 7.5, P9

66. Una paciente de 33 años, esquizofrénica, presenta galactorrea. Refiere ausencia de menstruaciones desde hace 4 meses, por lo que se realiza un test de embarazo, que resulta negativo. El diagnóstico más probable es:

a. Hipogonadismo hipogonadotrópico
b. Prolactinoma hipofisiario
c. Hipogonadismo hipergonadotrópico
d. Síndrome de ovario poliquístico
e. Hiperprolactinemia secundaria a fármacos

Respuesta correcta: e. Hiperprolactinemia secundaria a fármacos

Explicación: La sospecha es una hiperprolactinemia, por el síndrome galactorrea-amenorrea. Como es esquizofrénica es presumible que está utilizando antipsicóticos, los que son fármacos antidopaminérgicos, los cuales son la primera causa de hiperprolactinemia (los otros son los antieméticos). Es correcto haber solicitado el test de embarazo, porque siempre se debe descartar en cualquier situación que pueda ser la causa de los síntomas o en que el manejo cambie, en caso de estar embarazada.

Fuente: Endocrinología y diabetes, cuestionario 7.5, P16

67. Mujer de 38 años, puérpera hace 6 meses. Durante el parto presentó importante hemorragia, secundaria a inercia uterina. Desde el comienzo presentó agalactia, por lo que debió alimentar exclusivamente con fórmula a su hijo. A pesar de lo anterior, persiste en amenorrea y se ha agregado astenia y adinamia importante. El diagnóstico más probable es:

a. Síndrome de Sheehan
b. Apoplejía apofisiaria
c. Tiroiditis postparto
d. Hiperprolactinemia
e. Hipogonadismo hipergonadotrófico

Respuesta correcta: a. Síndrome de Sheehan

Explicación: Es un síndrome de Sheehan clásico: hipopituitarismo, secundario a una hemorragia puerperal, que produce un infarto hipofisiario (recordar que la hipófisis se irriga con un sistema portal, es decir, con sangre venosa, a lo que se agrega que durante el embarazo la hipófisis aumenta su tamaño, por la proliferación de células mamotropas, lo que aumenta el riesgo de isquemia, en caso de hipovolemia por la hemorragia. Suele presentarse como astenia, amenorrea y agalactia.

Fuente: Endocrinología y diabetes, cuestionario 7.5, P19

68. Una paciente de 40 años se realiza una TAC de cerebro, por un TEC, que descarta lesiones traumáticas, pero que muestra un tumor hipofisiario de 4 mm de diámetro. No presenta síntomas su examen físico es normal. Se solicita TSH, T4, prolactina y somatomedina 1, que resultan normales. La conducta más adecuada es:

a. Observar evolución
b. Realizar cateterismo de senos petrosos
c. Solicitar prueba de supresión con dexametasona y prueba de estimulación con clonidina

d. Solicitar niveles plasmáticos de SHBG y TBG

e. Resolver quirúrgicamente

Respuesta correcta: a. Observar evolución

Explicación: La causa más frecuente de tumores hipofisiarios son los adenomas no funcionantes, que suelen encontrarse como hallazgos en las neuroimágenes, solicitadas por otras causas (como en este caso). Si son asintomáticos y no son hiperproductores de hormonas (por eso se solicitaron la prolactina y demás), simplemente se observan. Si son sintomáticos o hiperproductores, se operan (excepto los prolactinomas, que se tratan con agonistas dopaminérgicos: ej. bromocriptina).

Fuente: Endocrinología y diabetes, cuestionario 7.6, P9

69. Un paciente de 56 años consulta por astenia, intolerancia al calor y palpitaciones. Al examen físico se aprecia piel fina y sudorosa, por lo que se solicita una TSH y una T4 libre, que resultan ambas elevadas. ¿Qué diagnóstico es más probable?

a. Tiroiditis de Hashimoto

b. Enfermedad de Basedow Graves

c. Tiroiditis subaguda de Quervein

d. Hipertiroidismo por aporte exógeno de levotiroxina

e. Tumor hipofisiario productor de TSH

Respuesta correcta: e. Tumor hipofisiario productor de TSH

Explicación: Es una pregunta difícil, ya que se pregunta algo muy infrecuente. Sin embargo, tiene un hipertiroidismo secundario, dado que la T4 libre está elevada (hipertiroidismo), pero la TSH también está elevada, por lo que la única opción posible es el tumor hipofisiario, productor de TSH. - La A (Hashimoto) tendría TSH alta, con T4 libre baja, siendo un hipotiroidismo primario. - La B (EBG), C (TSQ) y D (T4 exógena) tendrían TSH suprimida, con T4 libre alta, siendo un hipertiroidismo primario.

Fuente: Endocrinología y diabetes, cuestionario 7.7, P2

70. Un paciente de 23 años es diagnosticado de enfermedad bipolar hace algunos meses, luego de presentar una manía severa y psicótica, por lo que está en tratamiento con litio y risperidona. Se logra mejoría significativa de sus síntomas psiquiátricos, sin embargo, presenta disfunción sexual, con dificultades para lograr y mantener la erección y disminución de la libido. Además, se ha sentido con menos energía y fuerza, a pesar que su estado de ánimo está estable. Su examen físico no muestra alteraciones. ¿Qué examen debe solicitarse para el estudio de su cuadro actual?

a. 17-hidroxiprogesterona

b. Prolactina

c. FSH, progesterona y estradiol

d. Resonancia magnética nuclear de hipófisis

e. TSH y T4 libre

Respuesta correcta: b. Prolactina

Explicación: Tiene una disfunción sexual, que puede estar relacionada a causas de salud mental como a patologías orgánicas. En este caso, que está con antipsicóticos, es importante descartar una hiperprolactinemia, que, a su vez, esté generando un hipogonadismo secundario. Junto con la prolactina, se suele solicitar la LH y testosterona plasmáticas. En hombres, la hiperprolactinemia habitualmente no produce ginecomastia ni galactorrea (solo lo hace muy excepcionalmente), sino que se presenta como un

hipogonadismo clínico. Los antidopaminérgicos (antipsicóticos y antieméticos) son la causa más frecuente de hiperprolactinemia, seguida de los tumores hipofisiarios.

Fuente: Endocrinología y diabetes, cuestionario 7.8, P4

Metabolismo del calcio y hueso (12)

71. Un paciente de 70 años consulta por un cuadro de astenia y malestar general. Se solicitan exámenes que muestran calcemia: 14,8 mg/dl, albúmina plasmática: 3,6 g/dl, PTH: disminuida, fosfatasas alcalinas: elevadas. El diagnóstico más probable es:

a. Hiperparatiroidismo primario
b. Cáncer medular de tiroides
c. Hipercalcemia maligna
d. Hipercalcemia ficticia
e. Insuficiencia suprarrenal

Respuesta correcta: c. Hipercalcemia maligna

Explicación: Lo primero es corregir la calcemia, por albúmina, aunque en este caso, al corregirla, sigue habiendo hipercalcemia importante. Lo segundo es ver la PTH: si está alta, es hiperparatiroidismo primario. Si está baja (como en este caso) es hipercalcemia maligna. Las fosfatasas alcalinas se elevan en ambas causas. La fórmula de corrección de la calcemia es la siguiente: Calcio corregido = Calcio + 0,8 x (4 - albúmina) Calcio corregido = 14,8 + 0,8 x (4 - 3,6) Calcio corregido = 14,8 + 0,8 x 0,4 Calcio corregido = 14,8 + 0,32 Calcio corregido = 15,12 Como puede verse, cuando la albúmina es cercana a 4 (como en este caso), es poco lo que varía. Además, cuando la albúmina es menor a 4, la corrección será al alza, mientras que cuando es mayor a 4, la corrección será a la baja. Sabiendo esto se puede hacer más rápido, sin siquiera calcular.

Fuente: Endocrinología y diabetes, cuestionario 7.1, P1

72. Un paciente presenta hipercalcemia e hipofosfemia, asociadas a litiasis renal y osteoporosis. El diagnóstico más probable es:

a. Insuficiencia renal crónica
b. Hiperparatiroidismo primario
c. Hipercalciuria primaria
d. Hipercalcemia maligna
e. Hipervitaminosis D

Respuesta correcta: b. Hiperparatiroidismo primario

Explicación: El hiperparatiroidismo primario se caracteriza por PTH elevada, lo que genera hipercalcemia e hipofosfemia. El exceso de PTH produce osteoporosis y dolores óseos y la hipercalcemia se traduce en hipercalciuria, generándose no solo litiasis, sino nefrocalcinosis. Recordar que la PTH "hace todo lo posible por aumentar el calcio". - La IRC (que genera un hiperparatiroidismo secundario) tendría hipocalcemia e hiperfosfemia. - La hipercalcemia maligna tendría fósforo elevado. - La hipervitaminosis D es rara y produce hipercalcemia, pero con hiperfosfemia y sin dolor óseo ni pérdidas renales de calcio. Recordar que la vitamina D "hace todo lo posible por cuidar los huesos".

Fuente: Endocrinología y diabetes, cuestionario 7.2, P14

73. Una mujer de 70 años se realiza una densitometría ósea como estudio de rutina, obteniéndose un Z-score de -0,3 y un T-score de -2,1. El diagnóstico más probable es:

a. Sana
b. Osteopetrosis
c. Osteopenia
d. Osteoporosis postmenopáusica
e. Osteoporosis secundaria

Respuesta correcta: c. Osteopenia

Explicación: El T-score está entre – 1 y – 2,5, por lo que se trata de una osteopenia. La osteoporosis tiene un T-score menor o igual a – 2,5, ya que desde ahí comienza el riesgo de fracturas. El Z-score sirve para identificar la causa y si es menor o igual a – 2, se sospecha una causa secundaria y se debe seguir estudiando con múltiples exámenes (calcio, PTH, calciuria de 24 horas, hemograma, múltiples pruebas hormonales, etc. En resumen: T score hace el diagnóstico y Z score diferencia causas primarias de secundarias. En este caso es una osteopenia primaria.

Fuente: Endocrinología y diabetes, cuestionario 7.3, P3

74. Un paciente de 35 años acude a control médico, con un perfil bioquímico, que como única alteración muestra una calcemia de 12,5 mg/dl. La albúmina plasmática es de 4,0 g/dl. La conducta más adecuada es:

a. Solicitar PTH
b. Solicitar calcio iónico
c. Solicitar colonoscopía, radiografía de tórax y TAC de abdomen y pelvis
d. Iniciar furosemida y controlar en 3 meses
e. Iniciar hidroclorotiazida y controlar en 3 meses

Respuesta correcta: a. Solicitar PTH

Explicación: Tiene una hipercalcemia (calcio mayor a 10,5) y toda hipercalcemia se debe estudiar con PTH (paratohormona). Dado que la albúmina es 4,0 g/dl, al corregir el calcio por albúmina, no hay cambios. Calcio corregido = Calcio + 0,8 x (4 - albúmina) = 10,5 + 0,8 x (4-4) = 10,5 + 0,8 x 0 = 10,5.

Fuente: Endocrinología y diabetes, cuestionario 7.3, P8

75. Una paciente consulta por astenia. Trae un perfil bioquímico, en el que destaca una calcemia de 13,4 mg/dl, con fosfemia de 6,0 mg/dl, albuminemia de 3,0 mg/dl. Se solicitan niveles plasmáticos de PTH, los que resultan bajos. El diagnóstico más probable es:

a. Hipercalcemia ficticia
b. Hipercalcemia maligna
c. Hipervitaminosis D
d. Hiperparatiroidismo secundario
e. Hiperparatiroidismo primario

Respuesta correcta: b. Hipercalcemia maligna

Explicación: Tiene una hipercalcemia. Al ajustar el calcio por albúmina resulta 14,2 mg/dl, lo que sigue siendo hipercalcemia (si se hubiese normalizado, sería ficticia). Como la PTH está baja, lo más probable es que sea secundaria a cáncer, lo que también es compatible con la hiperfosfemia. - En cambio, el hiperparatiroidismo primario tiene PTH alta y fosfemia baja. - la hipervitaminosis D es posible, pero es

mucho menos frecuente que la hipercalcemia maligna. Calcio corregido = calcio + 0,8 x (4 - albúmina) = 13,4 + 0,8 x (4 - 3) = 13,4 + 0,8 = 14,2.

Fuente: Endocrinología y diabetes, cuestionario 7.4, P4

76. Una mujer de 30 años se realiza una radiografía de tórax, en contexto del estudio de un cuadro de dolor torácico, objetivándose una fractura del cuerpo vertebral, asociada a signos radiológicos de osteopenia, por lo que se decide solicitar una densitometría ósea que muestra un T-score de –3,0 y un Z-score de –2,4. El diagnóstico más probable es:

a. Sana
b. Osteopetrosis
c. Osteopenia
d. Osteoporosis primaria
e. Osteoporosis secundaria

Respuesta correcta: e. Osteoporosis secundaria

Explicación: El T-score menor o igual a –2,5 es diagnóstico de osteoporosis (entre –1 y –2,4 es osteopenia). El Z-score menor o igual a –2,0 indica que es una causa secundaria. La edad de 30 años también confirma que es secundaria. Vale la pena mencionar que el solo hecho de haber tenido una fractura vertebral espontánea ya es diagnóstico de osteoporosis, incluso con densitometría en rango de osteopenia, ya que la presencia de fracturas clásicamente osteoporóticas (ej. fractura de cadera, sin un trauma muy grave), per sé, es diagnóstica de osteoporosis. En este caso la densitometría es concordante. La importancia del diagnóstico de osteoporosis es que requiere no solo calcio, vitamina D y ejercicios, sino bifosfonatos (ej. ácido zolendrónico). La importancia de que sea secundaria es que requiere de estudio adicional, en busca de la causa (hiperparatiroidismo, hipercalciuria primaria, enfermedad celíaca, Cushing).

Fuente: Endocrinología y diabetes, cuestionario 7.4, P7

77. Paciente de 57 años, cursando síndrome nefrótico, secundario a nefropatía membranosa. En sus exámenes destaca hipercolesterolemia, albúmina:2,0 mg/dl, creatinina:1,1 mg/dl, Ca:7,5 mg/dl, con sodio, potasio y cloro normales. La causa más probable de su hipocalcemia es:

a. Hipercalciuria primaria
b. Hipocalcemia por insuficiencia renal crónica
c. Hipocalcemia ficticia
d. Hipovitaminosis D
e. Hipocalcemia por diuréticos

Respuesta correcta: c. Hipocalcemia ficticia

Explicación: Lo primero es ajustar la calcemia por albúmina. Calcio corregido = Calcio + 0,8 x (4 – albúmina) Calcio corregido = 7,5 + 0,8 x (4 – 2) Calcio corregido = 9,1 Por tanto, no hay hipocalcemia real, sino solo dada por la baja en la albúmina. - La recomendación para estos casos es solo perder tiempo en calcular si la albúmina es muy distinta a 4, como en este ejemplo. Si es cercana a 4, la variación será mínima. - Recordar, además, que el calcio iónico no requiere corrección, porque precisamente se pide para evitar las variaciones producidas por cambios en la proteinemia.

Fuente: Endocrinología y diabetes, cuestionario 7.5, P11

78. Un paciente de 75 años, fumador importante, presenta un cuadro de malestar general y debilidad muscular progresiva, asociado a náuseas y constipación, que luego se acompaña de compromiso de conciencia. Al examen físico se aprecia deshidratado, sin signos focales. El diagnóstico más probable es:

a. SSIADH
b. Síndrome de secreción ectópica de ACTH
c. Hipercalcemia
d. Enfermedad de Addison
e. Coma mixedematoso

Respuesta correcta: c. Hipercalcemia

Explicación: Es un cuadro clásico de hipercalcemia maligna (constipación, malestar, deshidratación y compromiso de conciencia), probablemente secundario a un cáncer de pulmón (tanto espinocelular, como de células pequeñas lo producen). El SSIADH tendría hiponatremia y compromiso de conciencia, por el edema cerebral de la hiponatremia. También podría tener vómitos, pero no constipación ni signos de deshidratación. El síndrome de ACTH ectópica se presenta como un síndrome de Cushing. La enfermedad de Addison tendría hiperpigmentación, más insuficiencia suprarrenal. El coma mixedematoso tendría compromiso de conciencia, con constipación, pero edema, en lugar de signos de deshidratación.

Fuente: Endocrinología y diabetes, cuestionario 7.6, P3

79. ¿Cuál de las siguientes fracturas puede ser considerada como osteoporótica?

a. Fractura de columna
b. Fractura de diáfisis humeral
c. Fractura de pierna
d. Fractura de rodilla
e. Fracturas costales

Respuesta correcta: a. Fractura de columna

Explicación: Las fracturas osteoporóticas son las vertebrales (las más frecuentes), las de cadera, muñecas y húmero proximal. Es decir, en general, huesos esponjosos.

Fuente: Endocrinología y diabetes, cuestionario 7.6, P5

80. Un paciente de 40 años sufre una fractura de muñeca, por una caída a nivel. Se solicita una densitometría ósea, que muestra Z-score de -2,1 y T-score de -2,7. El diagnóstico más probable es:

a. Osteopenia primaria
b. Osteopenia secundaria
c. Osteoporosis primaria
d. Osteoporosis secundaria
e. Sana

Respuesta correcta: d. Osteoporosis secundaria

Explicación: Tiene osteoporosis, por tener T-score menor o igual a –2,5. Es secundaria, por tener Z-score menor o igual a –2. Requiere de vitamina D, calcio y bifosfonatos por tener osteoporosis. Además, requiere de estudio con múltiples exámenes en busca de una patología que la cause, debido a que es secundaria.

Fuente: Endocrinología y diabetes, cuestionario 7.7, P4

81. Un paciente de 50 años se realiza un perfil bioquímico, en el que destaca calcemia 13,6 mg/dl, albuminemia: 4,5 g/dl y fosfemia: 3,5 mg/dl. La conducta más adecuada es:

a. Observar evolución
b. Solicitar PTH
c. Solicitar cintigrafía ósea
d. Solicitar densitometría ósea
e. Iniciar vitamina D

Respuesta correcta: b. Solicitar PTH

Explicación: Tiene una hipercalcemia. Al corregirla por albúmina queda en 13,2 mg/dl, por lo que sigue siendo mayor a 10,5. La hipercalcemia se estudia con PTH: si está elevada, hay un hiperparatiroidismo primario. Si está baja, probablemente sea cáncer.

Fuente: Endocrinología y diabetes, cuestionario 7.7, P7

82. Un paciente se realiza un perfil bioquímico, entre los que destaca calcemia de 12 mg/dl. Se solicitan nuevos exámenes, que muestran calcemia 12,3 mg/dl, calcio iónico: 6,0 (VN: 4,5 a 5,0 mg/dl), paratohormona: 68 pg/ml (VN: 10 - 55 pg/ml) y albuminemia: 3,5 g/dl. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

a. Hiperparatiroidismo primario
b. Hiperparatiroidismo secundario
c. Hipercalcemia ficticia
d. Hipercalcemia facticia por uso de fármacos o vitamina D
e. Hipercalcemia maligna

Respuesta correcta: a. Hiperparatiroidismo primario

Explicación: Tiene calcio elevado, que no es ficticio, dado que el calcio iónico está elevado y también lo está el calcio corregido por albúmina, por lo que la hipercalcemia está demostrada. Como la PTH está elevada, pues el diagnóstico es un hiperparatiroidismo primario, con una altísima probabilidad. Recordar que calcio corregido = calcio + 0,8 x (4 - albúmina) = 12 + 0,8 x 0,5 = 12 + 0,4 = 12,4.

Fuente: Endocrinología y diabetes, cuestionario 7.8, P5

Trastornos del sodio y del agua: SIADH y diabetes insípida (10)

83. ¿Cuál de las siguientes patologías es causa de hiponatremia?

a. Diabetes insípida
b. Enfermedad de Cushing
c. Hipogonadismo hipogonadotrópico
d. Síndrome de secreción inadecuada de hormona antidiurética
e. Hipertiroidismo

Respuesta correcta: d. Síndrome de secreción inadecuada de hormona antidiurética

Explicación: El exceso de ADH produce retención de aguda y por tanto, hiponatremia. Otras causas endocrinas son el hipotiroidismo y la insuficiencia suprarrenal. La diabetes insípida, por el contrario, produce hipernatremia.

Fuente: Endocrinología y diabetes, cuestionario 7.1, P7

84. Una paciente de 43 años sufre un accidente de tránsito, con golpe en la cabeza. Evoluciona con poliuria y polidipsia. Se solicitan una glicemia, que resulta normal. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

a. Iniciar una tiazida
b. Indicar restricción de agua libre a 800 cc al día
c. Solicitar niveles plasmáticos de ADH
d. Solicitar osmolaridades plasmática y urinaria
e. Iniciar tratamiento con furosemida

Respuesta correcta: d. Solicitar osmolaridades plasmática y urinaria

Explicación: La sospecha es una diabetes insípida, de tipo central (por lesión hipofisiaria). La forma de diagnosticarla es con sodio y osmolaridades urinarias y plasmáticas basales y post-privación de agua (aparece hipernatremia y mantiene orinas diluidas, a pesar de la privación de agua). Eso sí, si tiene hipernatremia en los exámenes, se confirma el diagnóstico sin necesidad de privar al paciente de agua, ya que habría riesgo de una hipernatremia más grave con hemorragia cerebral. Se trata con desmopresina intranasal, asegurando además una ingesta de agua adecuada. - Vale la pena recordar que el SSIADH (causa de hiponatremia) también se puede producir por un trauma craneano, pero su clínica es completamente diferente. - El SSIADH es lo que se trata con restricción de agua.

Fuente: Endocrinología y diabetes, cuestionario 7.2, P2

85. hombre de 50 años, fumador de 50 paquetes años, con antecedente de disnea de 3 meses de evolución, asociada a tos, sin estudio, acude a urgencias por deterioro progresivo de sus funciones cognitivas, incluyendo desorientación y sopor. No tiene antecedentes de trauma. La exploración física no muestra otras alteraciones. Sus exámenes de laboratorio muestran: Na+ plasmático 118 mEq/l, osmolalidad plasmática 240 mOsm/kg, glicemia 90 mg/dl, urea 22 mg/dl. Osmolalidad urinaria: 290 mOsm/kg, Na+ urinario: 35 mEq/l. ¿Cuál de los siguientes cuadros es el más probable?:

a. Insuficiencia suprarrenal crónica.
b. Diabetes insípida central.
c. Polidipsia compulsiva.
d. Síndrome de secreción inadecuado de hormona antidiurética (SSIADH).
e. Reajuste del osmostato.

Respuesta correcta: d. Síndrome de secreción inadecuado de hormona antidiurética (SSIADH).

Explicación: Es un SSIADH clásico: hiponatremia, asociada a una patología pulmonar o del sistema nervioso central. Además tiene la osmolaridad urinaria mayor a 200 mOsm/L, lo que es característico (no puede tener orinas diluidas y, para la natremia que tiene, está muy concentrado). Dada la hiponatremia grave, se debe corregir el sodio, recordando que no se puede hacer muy rápido, con un máximo diario de 8 mEq/L (según algunas fuentes, puede ser hasta 12), ya que, si se hace muy agresivamente, hay riesgo de mielinolisis pontina. - La insuficiencia suprarrenal puede tener hiponatremia, pero tiene una clínica totalmente distinta. - La diabetes insípida tiende a la hipernatremia.

Fuente: Endocrinología y diabetes, cuestionario 7.2, P17

86. Un paciente de 75 años, fumador de 40 paquetes-año, presenta un cuadro de baja de peso y malestar general, de 2 meses de evolución, al que hoy se le agregó compromiso de conciencia. En sus exámenes destaca una natremia de 120 mEq/L. El diagnóstico más probable es:

a. Síndrome de secreción ectópica de ACTH
b. Enfermedad de Cushing

c. Enfermedad de Addison
d. Síndrome de secreción inadecuada de hormona antidiurética
e. Diabetes insípida

Respuesta correcta: d. Síndrome de secreción inadecuada de hormona antidiurética

Explicación: El SSIADH es una causa frecuente de hiponatremia y se asocia a cualquier patología pulmonar y del sistema nervioso central. En este caso, probablemente hay un cáncer pulmonar de base, que produjo el SSIADH. El compromiso de conciencia se explica por la misma hiponatremia, por lo que la conducta debe ser el tratamiento con suero hipertónico endovenoso, a pasar lento.

Fuente: Endocrinología y diabetes, cuestionario 7.3, P4

87. Un paciente con antecedente de cáncer de pulmón presenta, entre sus exámenes, una natremia de 129 mEq/L. No presenta síntomas y se ve de buen aspecto. La conducta más adecuada para el manejo de su alteración hidroelectrolítica es:

a. Indicar un diurético tizídico
b. Indicar un diurético de asa
c. Restringir la ingesta de agua
d. Aumentar la ingesta de sodio
e. Administrar suero fisiológico endovenoso

Respuesta correcta: c. Restringir la ingesta de agua

Explicación: El diagnóstico más probable es un SSIADH, que se trata con restricción de agua a menos de 800 cc al día. Por otro lado, las hiponatremias asintomáticas y mayores a 120 mEq/L, se tratan de esa forma cuando se asocian a edema, IRC o SSIADH.

Fuente: Endocrinología y diabetes, cuestionario 7.4, P9

88. Un paciente psiquiátrico presenta un cuadro de polidipsia y poliuria, que ha ido en aumento, orinando cerca de 6 litros al día. Se solicita glicemia de ayuno que resulta 80 mg/dl. Su natremia basal es 140, con osmolaridad plasmática de 287 mOsm/L y osmolaridad urinaria: 170 mOsm/L. Se repiten los exámenes luego de varias horas sin ingerir agua y se constata natremia de 149 mEq/L, osmolaridad plasmática de 310 mOsm/L y osmolaridad urinaria de 180 mOsm/L. El diagnóstico más probable es:

a. Diabetes insípida
b. SSIADH
c. Polidipsia psicógena
d. Ingesta crónica de hidroclorotiazida
e. Ingesta crónica de furosemida

Respuesta correcta: a. Diabetes insípida

Explicación: Es una pregunta difícil, ya que hay que saberse los valores normales de la osmolaridad, en el test de la sed. La osmolaridad plasmática normal es 285 +/- 10 mOsm/L. La urinaria tiene un rango muy amplio (50 a 1200 mOsm/L), ya que depende de la ingesta de agua, pero si está bajo 200 se puede decir que está baja y si está sobre 200, se puede decir que está alta. Por tanto, en este caso tenemos una diabetes insípida, ya que aparece hipernatremia con la privación de aguda y la orina se mantiene diluida. El antecedente de que sea psiquiátrico, orientaba tanto a una polidipsia primaria, como a una diabetes insípida, por ejemplo, por consumo de litio.

Fuente: Endocrinología y diabetes, cuestionario 7.4, P13

89. Una paciente de 43 años sufre un accidente de tránsito, con golpe en la cabeza. Evoluciona con hiponatremia de 128 mEq/L. Se solicitan pruebas de función renal, que resultan normales y además se constata una osmolaridad urinaria de 300. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

a. Iniciar una tiazida
b. Indicar restricción de agua libre a 800 cc al día
c. Solicitar niveles plasmáticos de ADH
d. Solicitar TAC de silla turca
e. Iniciar tratamiento con furosemida

Respuesta correcta: b. Indicar restricción de agua libre a 800 cc al día

Explicación: Tiene un SSIADH, que se trata con restricción de agua. Además, la hiponatremia leve (mayor de 120 y asintomática) se trata de esa forma, cuando viene asociada a edema, IRC o SSIADH.

Fuente: Endocrinología y diabetes, cuestionario 7.5, P2

90. ¿Qué examen es más adecuado para determinar el origen central o nefrogénico de una diabetes insípida?

a. Osmolaridad urinaria basal y postprivación de agua
b. Prueba de respuesta a desmopresina
c. Sodio urinario de 24 horas
d. Niveles plasmáticos de ADH
e. TAC de silla turca

Respuesta correcta: b. Prueba de respuesta a desmopresina

Explicación: La diabetes insípida (DI) se diagnostica con el test de la sed (eso sí, si basalmente tiene hipernatremia, es peligroso privarlo de agua, por lo que se confirma en diagnóstico de inmediato). Luego, se clasifica en DI central y nefrogénica, según el test de desmopresina: si responde a desmopresina es central; si no responde, es nefrogénica. Los niveles de ADH son muy erráticos, por lo que nunca se piden.

Fuente: Endocrinología y diabetes, cuestionario 7.5, P14

91. La diabetes insípida se caracteriza por:

a. Poliuria, polidipsia, hiponatremia, hiperkalemia y acidosis metabólica
b. Poliuria, polidipsia, orinas concentradas y tendencia a la hiponatremia
c. Poliuria, polidipsia, orinas concentradas y tendencia a la hipernatremia
d. Poliuria, polidipsia, orinas diluidas y tendencia a la hiponatremia
e. Poliuria, polidipsia, orinas diluidas y tendencia a la hipernatremia

Respuesta correcta: e. Poliuria, polidipsia, orinas diluidas y tendencia a la hipernatremia

Explicación: La diabetes insípida se caracteriza por ausencia de ADH (central) o de la acción de la ADH (nefrogénica). La ADH se encarga de reabsorber agua en el túbulo colector. Por tanto, su déficit se produce perdidas urinarias de agua, con hipernatremia y orinas diluidas, más la poliuria, que se compensa con sed y polidipsia.

Fuente: Endocrinología y diabetes, cuestionario 7.6, P6

92. El síndrome de secreción inadecuada de ADH se caracteriza por:

a. Hipernatremia, hipokalemia e hipertensión arterial
b. Hipernatremia, con orinas concentradas

c. Hiponatremia, con orinas diluidas
d. Hipernatremia, con orinas diluidas
e. Hiponatremia, con orinas concentradas

Respuesta correcta: e. Hiponatremia, con orinas concentradas

Explicación: El SSIADH produce un exceso de ADH (o vasopresina u hormona anticiurética), la que se encarga de reabsorber agua en el túbulo colector. Por tanto, se produce retención de agua, con hiponatremia y orinas concentradas.

Fuente: Endocrinología y diabetes, cuestionario 7.7, P10

Gónadas, amenorrea, pubertad y menopausia (11)

93. La asociación de amenorrea secundaria e hirsutismo es muy sugerente de:

a. Hiperplasia suprarrenal congénita
b. Climaterio
c. Hipogonadismo hipergonadotrópico
d. Síndrome de ovario poliquístico
e. Hipogonadismo hipogonadotrópico

Respuesta correcta: d. Síndrome de ovario poliquístico

Explicación: La amenorrea más hirsutismo es diagnóstico de SOP, ya que cumple con el criterio menstrual y con el criterio del hiperandrogenismo (clínico, en este caso, por el hirsutismo, aunque también existiría hiperandrogenismo cuando hay acné o alopecia de tipo masculina). * Solo cuando hay un criterio (solo oligomenorrea o solo hiperandrogenismo) se debe pedir la ecografía TV para confirmar la presencia de ovarios poliquísticos. De lo contrario, no es necesario y se puede proceder a tratar. * Solo cuando no hay hiperandrogenismo clínico, se debe pedir la testosterona total o, idealmente, el índice de andrógenos libres (testosterona / SHBG) para confirmar el hiperandrogenismo de laboratorio. * Si bien el diagnóstico sigue siendo con mínimo 2 de 3 criterios: menstrual, hiperandrogenismo y ecográfico, hay autores que se quedan solo con el criterio menstrual y el hiperandrogenismo clínico. * Se debe estudiar la presencia de dislipidemia, resistencia a la insulina e indagar sobre posible apnea del sueño. - La opción A (HSRC) produce una insuficiencia suprarrenal, más hiperandrogenismo, desde la infancia. - El climaterio produce un hipogonadismo hipergonadotrófico, con bochornos y los hipogonadismos, no tienen hirsutismo (que es signo de hiperandrogenismo, no de hipogonadismo).

Fuente: Endocrinología y diabetes, cuestionario 7.1, P5

94. Un paciente de 45 años consulta por impotencia. Refiere que ha disminuido su deseo sexual y que además se ha sentido más débil de lo habitual. Se solicitan exámenes, que demuestran disminución de la testosterona plasmática, por lo que se solicita LH, que resulta muy alta. ¿Cuál de las siguientes opciones es compatible con este cuadro?

a. Lesión hipotalámica
b. Tumor hipofisiario productor de LH
c. Hiperprolactinemia
d. Sección del tallo hipofisiario
e. Daño testicular

Respuesta correcta: e. Daño testicular

Explicación: Tiene un hipogonadismo (disminución de la testosterona), de tipo hipergonadotrópico (elevación de la LH), por lo que es de origen gonadal. La otra causa es el Sd. de Klinefelter, pero no aparece en las alternativas y además, es genético, por lo que se habría manifestado mucho antes. - La A (lesión hipotalámica), C (hiperprolactinemia) y D (sección del tallo hipofisiario) producen hipogonadismo hipogonadotrópico (LH baja). Recordar la frase "el hipo-hipo es hipo-hipo": el hipogonadismo hipogonadotrópico es hipotalámico o hipofisiario. En cambio, el hipogonadismo hipergonadotrópico es testicular. - Un tumor productor de LH es algo rarísimo, que tendría clínica de hipergonadismo.

Fuente: Endocrinología y diabetes, cuestionario 7.2, P9

95. Una mujer de 45 años inicia oligomenorrea, con ciclos menstruales cada 2 a 3 meses, a lo que se le agregan bochornos. ¿Cuál de las siguientes opciones es la más adecuada para iniciar terapia de reemplazo hormonal?

a. Estrógenos solos
b. Progestágenos solos
c. Estrógenos más progestágenos
d. Raloxifeno
e. Agonistas de la GnRH

Respuesta correcta: c. Estrógenos más progestágenos

Explicación: La terapia de reemplazo hormonal (TRH) está indicada como tratamiento de los bochornos o síntomas vasomotores. Si la paciente tiene útero, se indica estrógenos más progestágenos. El estrógeno más usado en TRH es el 17-beta-estradiol o E2. El progestágeno varía. Solo si está histerectomizada se indica estrógeno solo. * La vía de administración de la TRH es oral, salvo en casos con hipertrigliceridemia, trombofilia o colelitiasis (en estas enfermedades el "paso hepático" puede empeorarlas). * La duración suele ser 5 años (salvo en mujeres con falla ovárica prematura, en que se indica hasta los 5 años y luego se intenta bajar la dosis, hasta suspender). * Si solo hay síntomas genitales y no vasomotores, se prefieren los estrógenos tópicos (incluso, antes se puede probar con lubricación durante las relaciones sexuales). * La TRH está contraindicada en mujeres con antecedente personal de cáncer de mama, cáncer de endometrio o eventos cardiovasculares (coronario, AVE o TVP/TEP). En esos casos se usan antidepresivos, en especial citalopram o venlafaxina (sertralina y fluoxetina tienen menor eficacia). - Los progestágenos solo no se usan como TRH, sino como anticonceptivo, durante la lactancia. - El raloxifeno es un agonista selectivo del recepto de estrógeno, que hoy se utiliza poco, principalmente en el tratamiento de la osteoporosis en casos muy seleccionados, ya que aumenta los bochornos. Sí tiene buen perfil cardiovascular y no aumenta el riesgo de cáncer. - Los agonistas de la GnRH se usan como bloqueadores del eje hipotálamo- hipófisis-gónada, en la hormonoterapia del cáncer de próstata y para reducir el tamaño de la endometriosis o los miomas antes de la cirugía. - La tibolona es un medicamento aceptable como TRH, pero es menos efectiva que los estrógenos y sus beneficios no parecen ser significativos, en relación a la TRH convencional.

Fuente: Endocrinología y diabetes, cuestionario 7.2, P10

96. Una niña de 7 años presenta olor axilar adulto desde hace algunos días. Se puede afirmar que:

a. Ha iniciado su pubertad de manera precoz
b. Ha iniciado su pubertad normalmente
c. Probablemente presentará talla baja
d. Se debe descartar una hiperplasia suprarrenal congénita
e. Es una variante normal del desarrollo

Respuesta correcta: e. Es una variante normal del desarrollo

Explicación: El olor axilar suele ser signo de la adrenarquia (activación de las glándulas suprarrenales) y no es un signo puberal propiamente tal. El signo de pubertad más importante de las niñas es la telarquia y en los niños, la orquidarquia (aumento de volumen testicular), seguido del aumento del tamaño del pene. La pubarquia o desarrollo del vello púbico, se puede ver tanto en la adrenarquia, como en la pubertad propiamente tal. - Tanto la pubertad, como la adrenarquia suelen iniciar después de los 8 años en las niñas y 9 años en los niños. Sin embargo, la adrenarquia temprana (antes de esas edades) es algo frecuente y normal, sin ningún riesgo asociado, a diferencia de la pubertad precoz que sí tiene riesgo de talla baja. - Actualmente, se considera que la adrenarquia es un diagnóstico de descarte, por lo que se recomienda que, además de un completo examen físico y acabada historia clínica, a todos los niños con adrenarquia precoz se les solicite una edad ósea (radiografía de mano). Si muestra crecimiento acelerado, se debe terminar de estudiar con múltiples exámenes. Si está normal, en cambio, se puede observar, explicando la normalidad. En los exámenes (si se pide alguno), lo característico es la elevación de las DHEAs (dihidroepiandrosterona), o sea, de los andrógenos suprarrenales.

Fuente: Endocrinología y diabetes, cuestionario 7.2, P16

97. Hombre de 22 años, consulta por infertilidad. Al examen físico destacan testículos de tamaño pequeño. La testosterona plasmática está disminuida y la FSH aumentada. El espermiograma demuestra azoospermia. El diagnóstico más probable es:

a. Síndrome de Klinefelter
b. Disgenesia gonadal primaria
c. Hipopituitarismo
d. Hipogonadismo hipogonadotrópico
e. Orquitis atrófica idiopática

Respuesta correcta: a. Síndrome de Klinefelter

Explicación: Tiene un síndrome de Klinefelter clásico: hipogonadismo hipergonadotrópico, con atrofia testicular y azoospermia. Se confirma con el cariograma, que muestra un patrón 47XXY. Se presenta en 1 de cada 500 hombres. Suele tener talla normal. Clínicamente se presenta con una amplia variedad de síntomas, desde mínimas alteraciones, hasta testículos pequeños, hipospadia, retraso puberal y toda la clínica de un hipogonadismo. La testosterona suele estar baja o normal baja. La LH y FHS se elevan (hipogonadismo hipergonadotrópico). El tratamiento más importante es la testosterona de reemplazo. La infertilidad se ve caso a caso y se puede manejar con adopción, donante de esperma y, en algunos casos, es posible obtener espermatozoides del paciente y recurrir a técnicas de fertilización asistida. - La disgenesia gonadal primaria se puede presentar igual, pero es mucho más infrecuente.

Fuente: Endocrinología y diabetes, cuestionario 7.2, P20

98. Una mujer de 29 años presenta amenorrea, con disminución del estradiol plasmático y aumento marcado de la FSH y LH. El diagnóstico más probable es:

a. Alteración hipotalámica
b. Hiperprolactinemia
c. Anovulación crónica
d. Falla ovárica prematura
e. Síndrome de ovario poliquístico

Respuesta correcta: d. Falla ovárica prematura

Explicación: Tiene un hipogonadismo hipergonadotrófico (se elevan las gonadotropinas: FSH y LH), por lo que es de origen ovárico. Como tiene menos de 40 años, el diagnóstico es una menopausia precoz o también llamada falla ovárica prematura (la menopausia normal es después de los 40 años). En cambio, las alteraciones hipotalámicas o hipofisiarias son hipogonadotrópicas ("el hipo hipo es hipo hipo").

Fuente: Endocrinología y diabetes, cuestionario 7.4, P11

99. Una mujer de 25 años inicia oligomenorrea, con ciclos menstruales cada 2 a 3 meses, a lo que se le agregan acné. Se solicitan exámenes, que muestran elevación de la LH y del estradiol ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

a. Falla ovárica
b. Insuficiencia hipofisiaria
c. Falla hipotalámica
d. Síndrome de ovario poliquístico
e. Hiperprolactinemia

Respuesta correcta: d. Síndrome de ovario poliquístico

Explicación: Es un SOP clásico: oligomenorrea más hiperandrogenismo (acné). En los exámenes suele elevarse la testosterona, estradiol, LH e insulina. En cambio, disminuye la progesterona, por la anovulación.

Fuente: Endocrinología y diabetes, cuestionario 7.5, P10

100. ¿Cuál de las siguientes alteraciones es MENOS probable en una mujer luego de la menupausia?

a. Disminución de la densidad ósea
b. Disminución de los niveles plasmáticos de estrógenos
c. Disminución de los niveles plasmáticos de progesterona
d. Disminución de los niveles plasmáticos de gonadotropinas
e. Disminución de la masa muscular

Respuesta correcta: d. Disminución de los niveles plasmáticos de gonadotropinas

Explicación: La menopausia produce un hipogonadismo (baja estrógeno y progesterona) hipergonadotrófico (eleva FSH y LH), de tipo fisiológico. De hecho, se sospecha con niveles de FSH sobre 25 y es casi seguro si es que están sobre 40.

Fuente: Endocrinología y diabetes, cuestionario 7.5, P15

101. Una mujer de 40 años presenta amenorrea hace 4 meses. Al examen físico no tiene alteraciones y su prueba de embarazo resulta negativa. La conducta inicial más adecuada es:

a. Observar evolución
b. Solicitar niveles de estradiol, progesterona y ecografía transvaginal
c. Solicitar niveles de LH, estradiol y hormona antimülleriana
d. Solicitar niveles de FSH y LH
e. Solicitar niveles de TSH, prolactina, FSH, estradiol y progesterona

Respuesta correcta: e. Solicitar niveles de TSH, prolactina, FSH, estradiol y progesterona

Explicación: El estudio inicial de la amenorrea es con TSH y prolactina, ya que el hipotiroidismo y la hiperprolactinemia son causas muy frecuentes, sin embargo, por tener 40 años, también es correcto descartar la menopausia, con FSH (y eventualmente estradiol y progesterona). De hecho, actualmente la amenorrea se estudia con muchos exámenes simultáneamente y no con el estudio clásico antiguo. Lo que

sí es importante destacar, es que se sigue iniciando el estudio con el test de embrazo, como examen más importante. La ecografía transvaginal suele ser muy importante para el estudio de las alteraciones menstruales (hipermenorrea, metrorragia), pero no tanto para la amenorrea en específico, ya que las causas uterinas son infrecuentes y se suele comenzar con los estudios hormonales. La hormona antimülleriana se puede pedir como un indicador de la reserva ovárica (si está muy baja sugiere que se está acercando la menopausia). La FSH es más importante que la LH en la menopausia. En cambio, en hombres, la LH suele ser más importante que la FSH para el estudio del hipogonadismo. Sin embargo, es correcto pedir ambas.

Fuente: Endocrinología y diabetes, cuestionario 7.6, P7

102. Un hombre de 29 años consulta por infertilidad. Lleva dos años intentando tener hijos, sin conseguirlo. Al examen físico se aprecia distribución ginecoide del vello corporal, testículos de tamaño pequeño y en sus exámenes destaca espermiograma con azoospermia, testosterona baja y FSH y LH elevadas. El estudio debe proseguir con:

a. TAC de silla turca
b. Niveles plasmáticos de GnRH
c. Ecografía testicular
d. Cariograma
e. Niveles plasmáticos de 17-hidroxiprogesterona

Respuesta correcta: d. Cariograma

Explicación: La sospecha diagnóstica es un síndrome de Klinefelter (hipogonadismo hipergonadotrópico, con atrofia testicular y azoospermia), el que se diagnostica con el cariograma o cariotipo, que muestra un patrón 47 XXY. El tratamiento suele ser con testosterona para el hipogonadismo. La infertilidad suele tratarse con adopción, obtención de un donante de esperma y, en algunos casos, es posible obtener algunos espermios del paciente para ser utilizados en técnicas de fertilización asistida (in vitro, por lo general).

Fuente: Endocrinología y diabetes, cuestionario 7.7, P9

103. Una paciente de 24 años, sexualmente activa con pareja estable, consulta por amenorrea de 4 meses de evolución. Refiere que previamente sus reglas eran irregulares, cada 2 a 3 meses. Al examen físico, presenta sobrepeso, piel de la cara con acné y seborrea, sin otras alteraciones. Se realiza test de embarazo, que resulta negativo. Ella refiere que no tiene intenciones de embarazarse en el corto y mediano plazo, por lo que usa preservativo como método anticonceptivo. Al preguntársele dirigidamente, responde que se depila el mentón ocasionalmente. ¿Cuál es la conducta más adecuada para su manejo?

a. Iniciar anticonceptivos con levonorgestrel solo
b. Iniciar anticonceptivos combinados con etinilestradiol y drospirenona
c. Solicitar cortisol basal y postdexametasona
d. Solicitar 17-OH progesterona, LH, testosterona y dihidroepiandrosterona plasmáticas
e. Solicitar resonancia magnética nuclear de hipófisis y glándulas suprarrenales

Respuesta correcta: b. Iniciar anticonceptivos combinados con etinilestradiol y drospirenona

Explicación: Tiene un síndrome de ovario poliquístico confirmado, al tener la alteración menstrual más el hiperandrogenismo clínico. - No requiere de la ecografía transvaginal para objetivar los múltiples quistes ováricos, ya que el diagnóstico está claro con la sola clínica. - Se trata con ACO con acción antiandrogénica, a menos que, además, quiera embarazarse, en que hay que evaluar inducir la ovulación, en caso de que haya infertilidad. - El estudio de la amenorrea podría haber seguido con una prueba de

progesterona u otros exámenes, pero, en este caso es claro el diagnóstico y no se requiere mayor estudio. - Es correcto solicitar exámenes de patologías asociadas a resistencia a la insulina: triglicéridos, glicemia de ayuno e insulina, para calcular el HOMA.

Fuente: Endocrinología y diabetes, cuestionario 7.8, P3

Diabetes mellitus: diagnóstico y clasificación (3)

104. ¿Cuál de los siguientes pacientes tiene diagnóstico de diabetes mellitus?

a. Paciente asintomático, con glicemia de ayuno de 290 mg/dl
b. Paciente con glicemia de ayuno de 198, que se repite a los dos días, resultando 138
c. Paciente con test de tolerancia a la glucosa, con glicemia basal de 110 mg/dl, que llega a los 180 mg/dl a las 2 horas postingesta de 75 gramos de glucosa
d. Paciente con hemoglobina glicosilada de 6%
e. Paciente con un hemoglucotest de 400 mg/dl

Respuesta correcta: b. Paciente con glicemia de ayuno de 198, que se repite a los dos días, resultando 138

Explicación: La A tiene una glicemia sobre 200, pero le faltan los síntomas. La B cumple con el criterio de 2 glicemias mayores o iguales a 126 mg/dl, así que está hecho el diagnóstico. La C tiene una glicemia alterada de ayuno (basal entre 100 y 125) y además una intolerancia a la glucosa oral (postcarga entre 140 y 199). La D está normal. Hoy se acepta que la HbA1c mayor o igual a 6,5% es diagnóstica, pero en Chile no se utiliza ese criterio y la HbA1c solo se usa como el examen de elección para el seguimiento de la diabetes y no para su diagnóstico. La E no puede ser utilizada, porque el hemoglucotest no es un examen aceptado para el diagnóstico de diabetes. Por lo que debe solicitarse las glicemias venosas.

Fuente: Endocrinología y diabetes, prueba 1 (captura), P3

105. Paciente de 40 años, con antecedente de hipotiroidismo, presenta un cuadro de cetoacidosis diabética. No presenta antecedentes familiares de diabetes, sin antecedentes de importancia. Al examen físico, se encuentra IMC de 20,5. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

a. Diabetes mellitus 1
b. Diabetes mellitus 2
c. Diabetes mellitus LADA
d. Diabetes mellitus MODY
e. Cetoacidosis congénita

Respuesta correcta: c. Diabetes mellitus LADA

Explicación: La cetoacidosis hace pensar tanto en diabetes mellitus 1 y LADA: ambas son autoinmunes y bastantes severas. El antecedente de hipotiroidismo hace pensar en una causa autoinmune. El peso normal hace muy poco probable que sea una DM2 (dado que es adulto la primera sospecha siempre es una DM2). La respuesta correcta es DM LADA, que es autoinmune de aparición tardía. Si hubiese sido un niño, la respuesta hubiera sido DM1. Si es que hubiese sido obeso, sería una DM2. La diabetes MODY, es una diabetes genética, de buen pronóstico, característica de los niños, con resistencia a la insulina de causa genética (similar a la DM2, pero de los niños).

Fuente: Endocrinología y diabetes, prueba 1 (captura), P14

106. Un paciente de 60 años se realiza una glicemia de ayuno, que resulta 120 mg/dl. No ha presentado síntomas y su examen físico es normal. ¿Qué examen es más adecuado para proseguir el estudio de este paciente?

a. Test de tolerancia a la glucosa
b. Glicemia de ayuno
c. Índice de HOMA
d. Hemoglobina glicosilada
e. Insulinemia basal

Respuesta correcta: a. Test de tolerancia a la glucosa

Explicación: Recordar que si la glicemia es menor a 100 se considera normal y se da de alta; si está entre 100 y 125 se pide un TTGO y si está mayor a 125, se repite, para confirmar el diagnóstico de diabetes mellitus. En el embarazo, en cambio, las glicemias mayores o iguales a 100, se repiten.

Fuente: Endocrinología y diabetes, prueba 2 (captura), P3

Diabetes mellitus: tratamiento y control metabólico (11)

107. Un paciente diabético tipo 1, en tratamiento con insulina es esquema intensificado con dos dosis de insulina NPH y tres refuerzos con insulina cristalina, presenta los siguientes controles promedio con Hemoglucotest: Predesayuno: 150 / Postdesayuno: 170; Prealmuerzo: 90 / Postalmuerzo: 120; Precena: 80 / Postcena: 100. La conducta más adecuada es:

a. Aumentar la dosis de insulina NPH matinal
b. Aumentar la dosis de insulina NPH nocturna
c. Aumentar la dosis de insulina cristalina predesayuno
d. Aumentar la dosis de insulina cristalina prealmuerzo
e. Aumentar la dosis de insulina cristalina precena

Respuesta correcta: b. Aumentar la dosis de insulina NPH nocturna

Explicación: La glicemias preprandiales dependen de la insulina lenta (glargina o NPH) recibida hace varias horas atrás (ej. la de ayuno depende de la NPH nocturna). En cambio, las glicemias postprandiales dependen de la insulina rápida (ultrarrápida o cristalina), aunque también dependen de la glicemia preprandial y de la comida misma. En este caso, las glicemias predesayuno y postdesayuno son las que están elevadas, por lo que se debe aumentar la insulina NPH nocturna, para normalizar la glicemia predesayuno, lo que a su vez normalizará la postdesayuno. Recordar que el objetivo de glicemias es preprandiales menores a 100 mg/dl y postprandiales menores a 130 mg/dl, pero que lo más importante es la hemoglobina glicosilada menor a 7%, así que si estuviera normal (lo que no se muestra en la pregunta), lo correcto sería mantener el tratamiento.

Fuente: Endocrinología y diabetes, prueba 1 (captura), P5

108. Un paciente de 50 años, diabético tipo 2, en tratamiento con metformina 500 mg cada 8 horas, acude a control. Trae una hemoglobina glicosilada de 6,3% y una proteinuria de 24 horas en 200 mg/dl. Sin embargo, refiere que desde que inició la metformina, presenta diarrea y dolor abdominal. ¿Cuál es la conducta más adecuada para el control metabólico de este paciente?

a. Mantener la metformina y hacer hincapié en el cumplimiento de la dieta
b. Aumentar la dosis de metformina a 850 mg cada 8 horas
c. Agregar glibenclamida 5 mg cada 12 horas

d. Reemplazar la metformina por rosiglitazona
e. Reemplazar la metformina por glibenclamida

Respuesta correcta: e. Reemplazar la metformina por glibenclamida

Explicación: Tiene un buen control metabólico (HbA1c menor a 7%), por lo que está bien tratada su diabetes. Sin embargo, la diarrea y el dolor abdominal son parte de los efectos adversos clásicos de la metformina, por lo que es recomendable suspenderla y reemplazarla por otro fármaco. Antes, la metformina se reemplazaba por glitazonas (tiazolidinedionas), ya que ambas actúan disminuyendo la resistencia a la insulina, pero actualmente están obsoletas, por aumentar el riesgo cardiovascular. Por ello, de las opciones, la más aceptable es cambiarla por glibenclamida, aunque en estricto rigor, es mejor cambiarla por sitagliptina u otro DPP4. En cambio, cuando es la glibenclamida la que produce efectos adversos (normalmente hipoglicemias), se suele reemplazar por DPP4 sin mayores dudas.

Fuente: Endocrinología y diabetes, prueba 1 (captura), P7

109. Un paciente diabético tipo 2, en tratamiento con metformina 850 mg/8 horas y glibenclamida 5 mg en la mañana, acude a control, constatándose creatinina 1,0 mg/dl y hemoglobina glicosilada de 7,5%. La conducta más adecuada es:

a. Reemplazar la metformina por una glitazona
b. Subir la dosis de glibenclamida
c. Iniciar insulina
d. Mantener el tratamiento y controlar en 3 meses
e. Solicitar un test de tolerancia a la glucosa oral

Respuesta correcta: b. Subir la dosis de glibenclamida

Explicación: El control metabólico es insuficiente (HbA1c mayor a 7%), por lo que se debe avanzar en el tratamiento. No tienen ninguna indicación de insulina, ni contraindicaciones para los hipoglicemiantes orales. Dado que la metformina está en dosis elevadas, ya no se debe subir (en teoría se podría subir a 1g cada 8 horas, pero 850 mg es una dosis casi equivalente). La glibenclamida aún se puede subir, ya que la dosis máxima es 10 mg cada 12 horas.

Fuente: Endocrinología y diabetes, prueba 1 (captura), P11

110. Un paciente de 58 años, diabético tipo 2 en tratamiento con glibenclamida y metformina en dosis máximas, acude a control. Presenta hemoglobina glicosilada de 6,8% y glicemias de ayuno entre 90 y 120 mg/dl. Su examen físico es normal y el resto de sus exámenes son normales. La conducta más adecuada es:

a. Iniciar insulina NPH
b. Solicitar test de tolerancia a la glucosa
c. Suspender los hipoglicemiantes orales e iniciar insulina en esquema intensificado
d. Mantener el tratamiento
e. Agregar rosiglitazona al tratamiento

Respuesta correcta: d. Mantener el tratamiento

Explicación: Está bien controlado (HbA1c menor a 7%), por lo que no es necesario hacer ningún cambio. Que las glicemias de ayuno estén mayores a 100 mg/dl, no importa, mientras se mantenga el objetivo de la hemoglobina glicosilada.

Fuente: Endocrinología y diabetes, prueba 1 (captura), P12

111. Un paciente de 45 años, con antecedente de lupus eritematoso sistémico, en tratamiento con prednisona, presenta glicemia de ayuno 180 mg/dl y glicemias postprandiales sobre 210 mg/dl, siendo diagnosticada de diabetes mellitus. ¿Cuál es el tratamiento inicial en esta paciente?

a. Metformina
b. Glibenclamida
c. Pioglitazona
d. Sitagliptina
e. Insulina

Respuesta correcta: e. Insulina

Explicación: Es una diabetes asociada a uso de corticoides, con glicemias arriba de 200 mg/dl, por lo que el tratamiento de elección es la insulina.

Fuente: Endocrinología y diabetes, prueba 1 (captura), P13

112. Un paciente de 20 años, diabético tipo 1, en tratamiento con una dosis de Lantus (insulina glargina) en la noche y tres dosis de insulina cristalina, previas al desayuno, almuerzo y cena, presenta la siguiente tabla de glicemias promedio: Desayuno: HGT prepandial 80 / HGT postprandial 120; Almuerzo: 90 / 170; Cena: 100 / 190. Además su hemoglobina glicosilada es de 8%. La conducta más adecuada es:

a. Aumentar la dosis de Lantus
b. Aumentar la insulina cristalina del desayuno y del almuerzo
c. Aumentar la insulina cristalina del almuerzo y cena
d. Aumentar la dosis de Lantus y de las 3 insulinas cristalinas
e. Agregar una dosis matinal de Lantus

Respuesta correcta: c. Aumentar la insulina cristalina del almuerzo y cena

Explicación: La glicemias prepandial dependen de la insulina lenta (glargina o NPH) recibida hace varias horas atrás (ej. la de ayuno depende de la NPH nocturna). En cambio, las glicemias postprandiales dependen de la insulina rápida (ultrarrápida o cristalina), aunque también dependen de la glicemia preprandial y de la comida misma. En este caso, las glicemias postalmuerzo y postcena son las que están elevadas, por lo que se debe aumentar la insulina cristalina de esos horarios. Recordar que el objetivo de glicemias es preprandiales menores a 100 mg/dl y postprandiales menores a 130 mg/dl, pero que lo más importante es la hemoglobina glicosilada menor a 7%. La insulina lantus (glargina) se tendría que elevar si es que las glicemias precomidas estuvieran elevadas.

Fuente: Endocrinología y diabetes, prueba 2 (captura), P1

113. Un paciente de 55 años, diabético tipo 2 en tratamiento con metformina 500 mg c/12 horas, presenta hemoglobina glicosilada de 8,5%, creatinina plasmática de 1,8 mg/dl y proteinuria de 24 horas de 500 mg. La conducta más adecuada es:

a. Agregar glibenclamida
b. Aumentar la dosis de metformina
c. Iniciar insulina
d. Iniciar hemodiálisis
e. Hacer énfasis en el seguimiento de la dieta y correcto uso de los hipoglicemiantes orales y controlar con

Respuesta correcta: c. Iniciar insulina

Explicación: Por tener una IRC, con creatinina mayor a 1,4, están contraindicados los HGO y de elección es la insulina. En este caso, además tiene proteinuria, por lo que se debe iniciar un IECA. La HbA1c está en 8,5%, lo que muestra un mal control metabólico, pero per sé no indica la insulina. En cambio, si fuera mayor o igual a 9%, sería indicación de insulina. Al iniciar la insulina NPH se suele mantener la metformina y se puede mantener o suspender la glibenclamida, pero en este caso se debe suspender la metformina, por tener IRC.

Fuente: Endocrinología y diabetes, prueba 2 (captura), P6

114. Un paciente diabético tipo 2, acude a control ambulatorio. Actualmente está en tratamiento con metformina 850 mg cada 8 horas, aspirina 100 mg al día y enalapril 20 mg c/12 horas. En sus exámenes destaca creatinina 2,0 mg/dl, proteinuria 350 mg/dl, glicemia de ayuno: 140 mg/dl y HbA1c: 8,5%. La conducta más adecuada es:

a. Mantener el tratamiento y controlar en 3 meses
b. Aumentar la dosis de metformina
c. Agregar glibenclamida al tratamiento
d. Agregar rosiglitazona al tratamiento
e. Iniciar insulina

Respuesta correcta: e. Iniciar insulina

Explicación: Nuevamente, por la IRC (creatinina mayor a 1,4), están contraindicados los HGO e indicada la insulina.

Fuente: Endocrinología y diabetes, prueba 2 (captura), P8

115. Un niño de 8 años presenta un cuadro de astenia y baja de peso, de cerca de 2 semanas de evolución. Además, presenta poliuria y polidipsia importante. Se solicita una glicemia de ayuno, que resulta 220 mg/dl. La conducta más adecuada es:

a. Repetir la glicemia en 7 días
b. Iniciar insulina NPH en dos dosis
c. Iniciar insulina es esquema intensificado, con una dosis de insulina ultralenta (glargina) más refuerzos con insulina cristalina
d. Solicitar test de tolerancia a la glucosa
e. Iniciar dieta, ejercicio y metformina

Respuesta correcta: c. Iniciar insulina es esquema intensificado, con una dosis de insulina ultralenta (glargina) más refuerzos con insulina cristalina

Explicación: El diagnóstico es una diabetes mellitus, ya que cumple con el criterio de una glicemia mayor o igual a 200 (ya sea de ayuno o no), más síntomas de diabetes (poliuria, polidipsia, baja de peso). Por se un niño, se asume que la diabetes es tipo 1, es decir autoinmune y se inicia el tratamiento con insulina en esquema intensificado, que es el tratamiento de elección para este tipo de diabetes (y también para la diabetes LADA del adulto).

Fuente: Endocrinología y diabetes, prueba 2 (captura), P11

116. Un paciente diabético, tipo 2, en tratamiento con metformina en dosis máxima, acude a control con los siguientes registros de glicemias promedio: Predesayuno 90 / Postdesayuno 140; Prealmuerzo 110 / Postalmuerzo 170; Precena 115 / Postcena 180. Además presenta una hemoglobina glicosilada de 7,5%. La conducta más adecuada es:

a. Agregar glibenclamida y mantener la metformina

b. Iniciar glibenclamida y suspender la metformina

c. Iniciar insulina NPH matinal

d. Iniciar insulina NPH nocturna

e. Iniciar insulina cristalina junto con las 3 comidas

Respuesta correcta: a. Agregar glibenclamida y mantener la metformina

Explicación: Su control metabólico es insuficiente, ya que la HbA1c está mayor a 7%. Además, salvo las glicemias de ayuno, todas las glicemias están elevadas. No tiene ninguna indicación de insulina, ni contraindicación de los hipoglicemiantes orales. Además, está solo con metformina en dosis máximas, por lo que es posible agregar glibenclamida, lo que es la respuesta correcta.

Fuente: Endocrinología y diabetes, prueba 2 (captura), P13

117. Un paciente de 50 años, diabético tipo 2, en tratamiento con metformina 500 mg cada 8 horas, acude a control. Trae una hemoglobina glicosilada de 10,3% y una proteinuria de 24 horas en 500 mg/dl. ¿Cuál es la conducta más adecuada para el control metabólico de este paciente?

a. Mantener la metformina y hacer hincapié en el cumplimiento de la dieta

b. Aumentar la dosis de metformina a 850 mg cada 8 horas

c. Agregar glibenclamida 5 mg cada 12 horas

d. Agregar rosiglitazona

e. Iniciar insulina

Respuesta correcta: e. Iniciar insulina

Explicación: Tiene una hemoglobina glicosilada mayor o igual a 9%, por lo que tiene indicación de iniciar con insulina NPH nocturna (10 UI por lo general, aunque hay distintos esquemas). La metformina se debe mantener, porque no hay insuficiencia renal o daño hepático que la contraindique y porque está demostrado que el control metabólico es mejor al mantener los hipoglicemiantes orales. Además, por la proteinuria, se asume que hay nefropatía, por lo que deberá iniciar un IECA (ejemplo enalapril).

Fuente: Endocrinología y diabetes, prueba 2 (captura), P15

Complicaciones agudas de la diabetes (6)

118. Un paciente de 72 años, diabético tipo 2, en tratamiento con metformina, el que cumple de manera irregular, es traído al servicio de urgencia, por compromiso de conciencia. Los familiares refieren que desde hace 2 días está con tos con expectoración mucopurulenta y fiebre, pero que hoy empezó a decir palabras sin sentido y luego presentó tendencia a dormir. Al examen está en sopor profundo, sin signos focales, con signos de deshidratación, FC: 106x'; PA: 100/60 mmHg, T°: 38,7 °C y saturación arterial de oxígeno de 96%. Al examen pulmonar se auscultan crepitaciones en la base izquierda. Sus exámenes muestran hematocrito: 49%, blancos: 16.000 por mm3, plaquetas: 400.000 por mm3, glicemia 816 mg/dl, sodio: 143 mEq/L, potasio: 4,0 mEq/L, pH: 7,38 y bicarbonato: 23 mEq/L. La radiografía de tórax portátil muestra signos de condensación en el lóbulo inferior izquierdo. La conducta más adecuada es:

a. Administrar 1 litro de suero fisiológico + 1g de KCl endovenoso, iniciar insulina endovenosa y administrar bicarbonato por vía endovenosa

b. Administrar 1 litro de suero glucosado al 5% + 2g de NaCl + 1g de KCl, iniciar insulina endovenosa y administrar antibióticos endovenosos

c. Administrar 1 litro de suero fisiológico + 1g de KCl endovenoso, iniciar insulina endovenosa y administrar antibióticos por vía endovenosa

d. Administrar 1 litro de suero glucosado al 5% + 2g de NaCl + 1g de KCl, iniciar insulina endovenosa y administrar bicarbonato y antibióticos endovenosos

e. Administrar 1 litro de suero fisiológico, iniciar insulina endovenosa y administrar antibióticos por vía endovenosa

Respuesta correcta: c. Administrar 1 litro de suero fisiológico + 1g de KCl endovenoso, iniciar insulina endovenosa y administrar antibióticos por vía endovenosa

Explicación: Tiene un síndrome hiperglicémico hiperosmolar (glicemia mayor a 600 mg/dl y osmolalidad plasmática mayor a 320 mOsm/L; si bien no dan la osmolalidad, en general toda glicemia sobre 600 tiene además osmolalidad sobre 320 y la clínica es compatible: compromiso de conciencia, deshidratación). Se trata con suero fisiológico, como primera medida. Además, requiere de insulina cristalina endovenosa, siempre y cuando el K+ sea mayor a 3,2 mEq/L. También requiere K+ endovenoso en goteo (1g de KCl si el K+ está sobre 3,2; y 3g, si está bajo 3,2; aunque no se da, si el K+ es mayor a 5,0 mEq/L). Por regla general, el Sd. HGHO no requiere bicarbonato. Quien sí requiere bicarbonato es la cetoacidosis diabética y solo si el pH es menor a 6,9. Finalmente se debe tratar la causa de la descompensación, en este caso la neumonía, la que requeriría ceftriaxona endovenosa (por tratarse hospitalizado).

Fuente: Endocrinología y diabetes, prueba 1 (captura), P1

119. Un paciente diabético tipo 1, presenta un cuadro de desorientación y luego convulsiones, que fue precedido por palpitaciones y temblor de las extremidades superiores. El diagnóstico más probable es:

a. Mielinolisis pontina

b. Accidente vascular encefálico

c. Encefalopatía de Wernicke

d. Cetoacidosis diabética

e. Hipoglicemia

Respuesta correcta: e. Hipoglicemia

Explicación: Es una hipoglicemia clásica: síntomas simpaticomiméticos (palpitaciones y temblor), seguidos de síntomas neuroglucopénicos (convulsiones y compromiso de conciencia). La mielinolisis pontina es un cuadro grave, asociado a la corrección rápida de la hiponatremia, con suero hipertónico. Se caracteriza por compromiso de conciencia y tetraparesia. El AVE se caracteriza por signos focales de inicio súbito. La encefalopatía de Wernicke se caracteriza por el COCA (confusión, oftalmoparesia, coma y ataxia) y se debe al déficit de tiamina (vitamina B1), generalmente en pacientes alcohólicos o muy desnutridos. La cetoacidosis sí puede tener compromiso de conciencia, pero se caracteriza por polipnea, fetor a manzana, dolor abdominal, náuseas y clínica de DM descompensada (poliuria, polidipsia, etc.).

Fuente: Endocrinología y diabetes, prueba 1 (captura), P2

120. Una paciente de 12 años, diabética tipo 1, en tratamiento con insulina, es traída al servicio de urgencia, por compromiso de conciencia. Los familiares refieren que desde hace 2 días está cursando con una infección urinaria, pero que hoy empezó a decir palabras sin sentido y luego presentó tendencia a dormir. Al examen está en sopor profundo, deshidratada, FC: 100x'; PA: 90/60 mmHg, T°: 38,7 °C y saturación arterial de oxígeno de 98%. Al examen pulmonar se aprecia polipnea. Sus exámenes muestran, glicemia 416 mg/dl, cetonas +++ en orina, sodio: 130 mEq/L, potasio: 4,6 mEq/L, pH: 7,18 y bicarbonato: 13 mEq/L. La conducta más adecuada es:

a. Administrar suero fisiológico + 1g de KCl endovenoso, iniciar insulina endovenosa y administrar bicarbonato por vía endovenosa

b. Administrar suero glucosado al 5% + KCl endovenoso e iniciar insulina endovenosa

c. Administrar suero fisiológico + KCl endovenoso e iniciar insulina endovenosa

d. Administrar suero glucosalino + KCl, iniciar insulina endovenosa y administrar bicarbonato endovenoso

e. Administrar suero fisiológico + bicarbonato e iniciar insulina endovenosa

Respuesta correcta: c. Administrar suero fisiológico + KCl endovenoso e iniciar insulina endovenosa

Explicación: Tiene una cetoacidosis diabética ya diagnosticada (cuerpos cetónicos positivos, acidosis metabólica, glicemia menor a 7,3), con la clínica característica. Como está normal el K+ está indicada la insulina y el K+. Y como el pH está sobre 6,9, no requiere bicarbonato. La primera medida debe ser el suero fisiológico (o ringer) 20 cc/Kg de peso. Luego se inicia insulina y potasio, aunque no se debe dar insulina si hay hipopotasemia, ni se debe dar potasio si hay hiperpotasemia (por eso siempre se espera el resultado del potasio, antes de iniciar la insulina y el potasio. Además, se debe dar bicarbonato de sodio, pero solo si el pH es menor a 6,9 (si es mayor, la misma insulina normaliza el pH, al hacer desaparecer los cetoácidos).

Fuente: Endocrinología y diabetes, prueba 1 (captura), P8

121. Un paciente diabético tipo 1, presenta un cuadro de desorientación y luego coma, que fue precedido por marcado malestar general, náuseas y dolor abdominal. El diagnóstico más probable es:

a. Síndrome hiperglicémico hiperosmolar

b. Encefalopatía de Korsakov

c. Encefalopatía de Wernicke

d. Cetoacidosis diabética

e. Hipoglicemia

Respuesta correcta: d. Cetoacidosis diabética

Explicación: Es una cetoacidosis clásica: diabético 1, con síntomas abdominales (dolor y náuseas/vómitos), que luego evoluciona a compromiso de conciencia, polipnea. Los demás cuadros clínicos ya fueron explicados en otras respuestas.

Fuente: Endocrinología y diabetes, prueba 1 (captura), P9

122. Una paciente de 65 años, sin antecedentes mórbidos conocidos presenta un cuadro de palpitaciones, malestar y sudoración, luego de estar 5 horas sin comer. El cuadro se repite varias veces, siempre en relación al ayuno, por lo que decide hacerse un hemoglucotest, que demuestra una glicemia de 45 mg/dl durante uno de los episodios. ¿Qué examen es el más adecuado para determinar la etiología de la hipoglicemia?

a. Glicemia de ayuno

b. Test de tolerancia a la glucosa

c. Niveles plasmáticos de insulina

d. Niveles plasmáticos de glucagón

e. Niveles plasmáticos de péptido C

Respuesta correcta: e. Niveles plasmáticos de péptido C

Explicación: Tiene hipoglicemias de ayuno (recordar que las causas son los insulinomas, el cáncer, la IRC y el DHC). Se estudia con péptido C (porque es más estable que la insulina). Si está alto es un insulinoma; si está bajo se buscan las otras causas. En cambio las hipoglicemias reactivas (2 a 4 horas postprandiales) se estudian con el TTGO de larga duración.

Fuente: Endocrinología y diabetes, prueba 2 (captura), P4

123. Una paciente ha presentado 5 hipoglicemias, las que han requerido hospitalización en varias oportunidades. Niega antecedentes de importancia, pero los familiares sospechan que está autoinduciéndose los síntomas. En la última hospitalización se realiza estudio que revela insulina de 55 UI/L y péptido C elevado. ¿Cuál de los siguientes diagnósticos es más probable?

a. Hipoglicemia facticia por insulina
b. Hipoglicemia facticia por metformina
c. Hipoglicemia facticia por glibenclamida
d. Hipoglicemia facticia por pioglitazona
e. Hipoglicemia de ayuno

Respuesta correcta: c. Hipoglicemia facticia por glibenclamida

Explicación: Que el péptido C esté elevado significa que su páncreas está produciendo mucha insulina (la que está elevada también). La glibenclamida es una sulfonilúrea, por lo que aumenta la secreción de insulina (secretagogo), lo que es compatible con el cuadro. La insulina exógena tendría insulina alta, pero péptido C bajo. La metformina y la pioglitazona suelen no producir hipoglicemias, porque solo disminuyen la resistencia a la insulina. De todos modos, en caso de producirla, sería con insulina y péptido C bajos. Las hipoglicemias de ayuno, también son con péptido C e insulina bajos.

Fuente: Endocrinología y diabetes, prueba 2 (captura), P10

Complicaciones crónicas de la diabetes (3)

124. ¿Qué tratamiento está indicado ante la aparición de microalbuminuria persistente en un paciente con diabetes mellitus tipo 2?

a. Insulina
b. Dieta hipoproteica
c. Dieta hiperproteica
d. IECAs
e. Atorvastatina

Respuesta correcta: d. IECAs

Explicación: La microalbuminuria (mayor a 30 mg/día o RAC mayor a 0,03) persistente (mayor a 3 meses) es diagnóstica de nefropatía diabética inicial, que se maneja con IECA. La insulina sí está indicada en la nefropatía diabética, pero en la nefropatía establecida, con caída del clearence de creatinina y creatininemia mayor a 1,4.

Fuente: Endocrinología y diabetes, prueba 2 (captura), P5

125. Un paciente de 65 años, diabético tipo 2, de larga data, con tratamiento irregular con metformina y glibenclamida consulta por dolor intenso de la extremidad inferior izquierda, de tipo neurálgico, que recorre el dermatoma L4. Al examen físico se observa enflaquecido, con disminución de la sensibilidad distal y sin alteraciones motoras. La hemoglobina glicosilada resulta 9,9%. La conducta más adecuada es:

a. Reforzar el tratamiento con hipoglicemiantes orales y controlar en 3 meses
b. Suspender la glibenclamida y agregar insulina NPH nocturna
c. Indicar zapatos adecuados y revisión diaria de los pies y regularizar el tratamiento con hipoglicemiantes orales
d. Indicar un plan de ejercicios, reforzar la adhesión al tratamiento y controlar en 7 días
e. Hospitalizar, iniciar insulinoterapia y clomipramina oral

Respuesta correcta: e. Hospitalizar, iniciar insulinoterapia y clomipramina oral

Explicación: Tiene una neuropatía diabética dolorosa, por lo que se trata con ADTC (antidepresivos tricíclicos) e insulina. Además, por la HbA1c mayor a 9%, también está indicada la insulina. Probablemente se mantendrá la metformina.

Fuente: Endocrinología y diabetes, prueba 2 (captura), P7

126. Un paciente diabético tipo 2, en tratamiento con dieta, el que sigue de manera irregular, consulta por dolor en ambas extremidades inferiores, que es de tipo urente y que es especialmente intenso en la noche. Al examen presenta alodinia, sin focalidad neurológica, ni lesiones en la piel. La conducta más adecuada es:

a. Iniciar metformina y AINEs
b. Iniciar glibenclamida y clomipramina
c. Iniciar metformina y gabapentina
d. Iniciar insulina y clomipramina
e. Iniciar insulina y AINEs

Respuesta correcta: d. Iniciar insulina y clomipramina

Explicación: Tiene una neuropatía diabética dolorosa, por lo que se trata con ADTC (antidepresivos tricíclicos, como la clomipramina, imipramina y amitriptilina), más insulina. Recordemos que el diagnóstico de la neuropatía dolorosa es clínico (dolor neuropático, urente, con alodinia). La gabapentina y la pregabalina sí suelen usarse y son útiles, en particular en adultos mayores, en que están contraindicados los ADTC y cuando estos producen muchos efectos adversos. Sin embargo, los hipoglicemiantes orales no son suficientes y solo la insulina acelera la desaparición del dolor.

Fuente: Endocrinología y diabetes, prueba 2 (captura), P14

Dislipidemias y síndrome metabólico (4)

127. Un paciente de 58 años, obeso, presenta un perfil lipídico con triglicéridos de 210 mg/dl, colesterol LDL: 180 mg/dl, colesterol HDL: 35 mg/dl y colesterol total: 257. Se inicia dieta y ejercicios y se controla tres meses después, sin lograr cambios. Su glicemia de ayunas es de 110 mg/dl y su TTGO resulta 150 mg/dl a las 2 horas postcarga de glucosa. La conducta más adecuada es:

a. Iniciar una estatina y metformina
b. Iniciar un fibrato y metformina
c. Iniciar un fibrato y una estatina
d. Iniciar metformina
e. Mantener las indicaciones

Respuesta correcta: a. Iniciar una estatina y metformina

Explicación: Tiene varios diagnósticos: 1. Hipertrigliceridemia, 2. Hipercolesterolemia LDL, 3. HDL bajo, 4. Glicemia de ayuno alterada (GAA), 5. Intolerancia a la glucosa oral (IGO), 6. Obesidad y 7. Síndrome metabólico. Respecto a las dislipidemias, la prioridad es el LDL, porque los TG están bajo 500, por lo que se debe iniciar estatinas. Respecto al síndrome metabólico y a la GAA e IGO, todos se tratan con dieta y metformina. Recordemos los criterios diagnósticos del síndrome metabólico: al menos 3 de los siguientes: obesidad abdominal, HTA, hiperTG, HDL bajo, patologías derivadas de la resistencia a la insulina (GAA, IGO o DM2). No incluye alteraciones del LDL, que no se afecta cuantitativamente en la resistencia a la insulina, aunque sí se puede afectar cualitativamente, al volverse pequeño y denso y por tanto, más aterogénico.

Fuente: Endocrinología y diabetes, prueba 1 (captura), P10

128. Un paciente diabético de 50 años, en tratamiento con dieta, se realiza una prueba de lípidos, que muestra Colesterol LDL de 120 mg/dl, TG: 600 mg/dl, HDL: 30 mg/dl. La conducta más adecuada es:

a. Manejar con dieta
b. Iniciar insulina
c. Iniciar una estatina
d. Iniciar un fibrato
e. Iniciar ácido nicotínico

Respuesta correcta: d. Iniciar un fibrato

Explicación: Por ser diabético, la meta de LDL es menor a 70, por lo que está elevada. Además tiene TG elevados (> 150) y HDL bajo (<40), por lo que el diagnóstico es una dislipidemia mixta. Si bien la regla general es que el LDL es la prioridad, en este caso tiene TG mayores a 500, por lo que la hipertrigliceridemia pasa a ser la prioridad y se debe tratar con fibrato. Si los TG hubiesen sido menores a 500 (ej. 400), la respuesta habría sido la estatina.

Fuente: Endocrinología y diabetes, prueba 2 (captura), P2

129. Un paciente de 60 años, hipertenso, sufrió un infarto de pared anterior hace 1 año, el que fue manejado con angioplastía. Acude a control, con un perfil lipídico, con los siguientes valores: colesterol total: 220 mg/dl, colesterol HDL: 40 mg/dl, colesterol LDL: 160 mg/dl, triglicéridos: 100 mg/dl. Refiere no tomar ningún medicamento hipolipemiante ni seguir ninguna dieta. La conducta más adecuada para el manejo de sus lípidos es:

a. Observar evolución
b. Indicar dieta baja en grasas trans, grasas saturadas y colesterol y controlar en 3 meses
c. Indicar dieta e iniciar una estatina
d. Indicar dieta e iniciar un fibrato
e. Indicar dieta e iniciar una estatina, asociada a un fibrato

Respuesta correcta: c. Indicar dieta e iniciar una estatina

Explicación: Por tener un IAM previo, su riesgo cardiovascular es máximo y por tanto el objetivo de LDL es menor a 70 mg/dl. Además, tiene HDL bajo (menor a 40), pero TG normales (menores a 150). Por tanto, la prioridad será el manejo del LDL, lo que requiere una estatina, por tener riesgo cardiovascular máximo.

Fuente: Endocrinología y diabetes, prueba 2 (captura), P9

130. Un paciente de 56 años acude a control con el siguiente perfil lipídico: colesterol total: 348 mg/dl, colesterol HDL: 30 mg/dl, colesterol LDL: 190 mg/dl, triglicéridos: 640 mg/dl. La conducta más adecuada es:

a. Iniciar dieta y ejercicio
b. Iniciar dieta y una estatina
c. Iniciar dieta y un fibrato
d. Iniciar dieta y una asociación entre una estatina y un fibrato
e. Hospitalizar e iniciar insulina cristalina

Respuesta correcta: c. Iniciar dieta y un fibrato

Explicación: Tiene LDL elevado, TG elevados y HDL bajo. Por estar los TG sobre 500, pasan a ser la prioridad y se deben tratar con un fibrato. Recordar que los médicos generales nunca deben mezclar

fibratos con estatinas, ya que por un lado se dispara el riesgo de rabdomiólisis y por otro lado, todos los hipolipemiantes sirven en cierta medida para el tratamiento de las tres dislipidemias.

Fuente: Endocrinología y diabetes, prueba 2 (captura), P12

Nutrición y misceláneos (2)

131. Un paciente indigente, en situación de calle, ingresa al servicio de urgencia por un cuadro de desorientación y dificultades para caminar. Al examen físico se constata estrabismo divergente, por parálisis del tercer nervio craneal izquierdo, ataxia de la marcha y desorientación temporoespacial, sin otras alteraciones. El diagnóstico más probable es:

a. Hipoglicemia
b. Hipofosfemia
c. Síndrome hiperglicémico hiperosmolar
d. Encefalopatía de Wernicke
e. Encefalopatía de Korsakoff

Respuesta correcta: d. Encefalopatía de Wernicke

Explicación: Es una encefalopatía de Wernicke clásica, causada por déficit de tiamina (vitamina B1) y muy frecuente en los pacientes alcohólicos, que de hecho deben recibir la tiamina de manera profiláctica. Su diagnóstico es clínico y se caracteriza por el COCA (coma, oftalmoplejía, confusión y ataxia de la marcha). La hipoglicemia produce síntomas simpáticos/adrenérgicos (palpitaciones, sudoración, temblor), seguidos de síntomas neuroglucopénicos (convulsiones, compromiso de conciencia). La hipofosfemia produce un cuadro de compromiso de conciencia, con rabdomiólisis y anemia hemolítica. La encefalopatía de Korsakoff también es por déficit de B1, aunque es crónica y por daño permanente en los centros de la memoria, por lo que produce un cuadro de alteración de la memoria de corto plazo, pero también de largo plazo, lo que se caracteriza por la "confabulación", es decir, por rellenar los vacíos de la memoria con historias inventadas.

Fuente: Endocrinología y diabetes, prueba 1 (captura), P6

132. Paciente de 28 años, con diagnóstico de anorexia, desnutrida, que pesa 45 kilos y mide 1,75 metros, es hospitalizada para inicio de su alimentación por sonda nasogástrica, recibiendo una dosis de 2.000 calorías al día, en el primer día. Inicia con arritmia ventricular por torsión de puntas. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

a. Déficit de vitamina B1
b. Déficit de vitamina B12
c. Síndrome de realimentación
d. Hipercalcemia
e. Hipoglicemia severa

Respuesta correcta: c. Síndrome de realimentación

Explicación: El síndrome de realimentación, produce depleción aguda de oligoelementos, lo que se traduce en hipomagnesemia, hipocalemia e hipocalcemia, todo lo que alarga QT, produciendo torsión de puntas. Además, puede cursar con déficit de B1, hipofosfemia, baja aguda de zinc, cobalto, etc. La causa es una alimentación agresiva en un paciente crónicamente desnutrido. Por ello, la alimentación debe iniciarse con apenas 10 Kcal por Kg de peso al día (450 Kcal en este caso), más aporte de oligoelementos y subirse de a poco.

Fuente: Endocrinología y diabetes, prueba 1 (captura), P15

Infectología (135)

VIH/SIDA e infecciones oportunistas (23)

1. Un paciente de 35 años, diagnosticado de VIH recientemente, le pregunta por la necesidad de tratamiento. No ha presentado infecciones oportunistas y su examen físico es normal. En sus exámenes presenta Elisa VIH: positivo, Western Blot VIH: positivo, carga viral: 2.130 copias por ml, CD4+: 430. La recomendación más adecuada, de acuerdo a la OMS, es:

a. Debe recomendársele iniciar triterapia antirretroviral, de inmediato
b. Debe iniciar profilaxis para penumocystis carinii de inmediato
c. Debe iniciar triterapia y profilaxis para pneumocystis carinii de inmediato
d. Debe iniciar monoterapia con zidovudina, de inmediato
e. No debe iniciar terapia por ahora

Respuesta correcta: a. Debe recomendársele iniciar triterapia antirretroviral, de inmediato

Explicación: Tiene VIH en etapa 2A (2: CD4 entre 200 y 500 y A: sin infecciones oportunistas). La OMS recomienda iniciar la TAR siempre, independiente de la etapa. El Minsal aún no ha actualizado su guía, pero, en general, los infectólogos tratan a todos los pacientes VIH actualmente con TAR, tanto en el sistema público como en el privado (recordar que el VIH es una patología AUGE, por lo que el principal problema es la falta de diagnóstico y no los recursos para el tratamiento). La profilaxis para Pneumocystis se inicia si tiene menos de 200 CD4 x mm3.

Fuente: Infectología, cuestionario 9.2, P1

2. Un paciente VIH positivo presenta un cuadro de una semana de cefalea y malestar general, al que luego se le agrega sopor. Se solicita un TAC, que no muestra alteraciones. La conducta más adecuada es:

a. Iniciar ceftriaxona endovenosa
b. Iniciar cotrimoxazol
c. Iniciar vancomicina + ampicilina + cotrimozaxol
d. Solicitar serología para toxoplasma
e. Solicitar punción lumbar y estudio de líquido cefalorraquídeo

Respuesta correcta: e. Solicitar punción lumbar y estudio de líquido cefalorraquídeo

Explicación: Todo paciente VIH con compromiso de conciencia se debe estudiar con una RMN (idealmente) o con una TAC con contraste, para descartar toxoplasmosis (en este caso se descartó; suele verse como una lesión que capta contraste en anillo) y luego se debe estudiar con punción lumbar para descartar criptococosis, además de las demás causas de meningitis. La punción lumbar, incluso puede identificar la toxoplasmosis misma, aunque la TAC o RMN suelen ser más sensibles y ser los exámenes de elección para diagnosticar y tratar la toxoplasmosis. Vale la pena mencionar que el diagnóstico definitivo solo se puede hacer con una biopsia, pero, en la práctica no se realiza, sino que se trata y solo se biopsia si es que no responde (linfoma y criptococoma se pueden ver iguales).

Fuente: Infectología, cuestionario 9.2, P3

3. Un paciente VIH positivo, sin tratamiento, consulta por disfagia de 5 días de evolución. Al examen físico presenta algorra en la cavidad oral y se palpan algunas adenopatías cervicales. La conducta más adecuada es:

a. Iniciar tratamiento con fluconazol oral

b. Iniciar tratamiento empírico con antimicóticos, ganciclovir y aciclovir oral

c. Iniciar tratamiento con cotrimoxazol + macrólidos

d. Solicitar PPD

e. Solicitar endoscopía digestiva alta

Respuesta correcta: a. Iniciar tratamiento con fluconazol oral

Explicación: Es una pregunta difícil, ya que hay dos opciones potencialmente correctas. La disfagia en el paciente VIH, por regla general se debe estudiar con endoscopía digestiva alta (EDA), sin embargo, cuando se sospecha fuertemente una candidiasis esofágica, como en este caso, en que tiene candidiasis oral (algorra), lo más correcto es realizar una prueba terapéutica con fluconazol y, solo si no ha mejorado en 7 días, se debe hacer la EDA. El tratamiento de la candidiasis esofágica es con 21 días de fluconazol 400 mg/día. Otras causas de disfagia en el paciente VIH son la esofagitis por citomegalovirus y por herpes simplex. - En el embarazo, no se debe dar fluconazol oral, menos aún en estas dosis, ya que es teratogénico. Por ello, el tratamiento en el embarazo es nada menos que la anfotericina B liposomal (tiene más riesgo de hepatitis, pero menos riesgo fetal).

Fuente: Infectología, cuestionario 9.2, P9

4. El "periodo de ventana" de la infección por VIH se explica por:

a. El tiempo que toma al virus replicarse hasta alcanzar niveles detectables de partículas virales

b. El tiempo que el virus permanece latente, sin replicarse

c. El tiempo que toma al sistema inmune producir anticuerpos contra el virus

d. El tiempo que toma al virus para deteriorar el sistema inmune, de modo de volver al organismo susceptible para las infecciones oportunistas

e. El tiempo que toma a los linfocitos T CD4 positivos infectarse con el virus

Respuesta correcta: c. El tiempo que toma al sistema inmune producir anticuerpos contra el virus

Explicación: El periodo de ventana es aquel en que las pruebas de Elisa y Western Blot están falsamente negativas. Esto, porque ambas miden anticuerpos y existe un periodo de tiempo de 6 semanas a 3 meses, en que los niveles de anticuerpos son muy bajos como para detectarlos. Lo importante es que en el periodo de ventana, se debe hacer el diagnóstico midiendo directamente el virus, mediante la PCR para VIH o mediante la medición de proteínas virales, como el antígeno p24 (además de los anticuerpos). El ejemplo más clásico es el síndrome retroviral agudo, que suele tener Elisa negativo, pero PCR-VIH o P24 positivos.

Fuente: Infectología, cuestionario 9.2, P14

5. El tratamiento de la neumonía por Pneumocystis jiroveci, en el paciente VIH, es:

a. Albendazol

b. Metronidazol

c. Anfotericina B

d. Cotrimoxazol

e. Fluconazol

Respuesta correcta: d. Cotrimoxazol

Explicación: El cotrimoxazol es el tratamiento de elección de la infección por P. jiroveci. Si es alérgico a las sulfas, se pueden usar dapsona, pirimetamina, clindamicina o pentamidina (en general se usan dos de los anteriores).

Fuente: Infectología, cuestionario 9.2, P15

6. Un paciente de 40 años, asintomático, diagnosticado de VIH hace 2 años, sin tratamiento, acude a control de rutina por su enfermedad, en el que se constata recuento de linfocitos CD4(+) de 180 por mm3. Respecto a este paciente es cierto que:

a. Debe solicitarse un nuevo Elisa para VIH
b. Debe iniciarse tratamiento profiláctico antituberculoso
c. La triterapia está contraindicada
d. Debe iniciar cotrimoxazol oral como profilaxis de Pneumocyscis jiroveci
e. Debe realizarse una punción lumbar de urgencia

Respuesta correcta: d. Debe iniciar cotrimoxazol oral como profilaxis de Pneumocyscis jiroveci

Explicación: Tiene VIH en etapa 3A (3: menos de 200 CD4+ por mm3; A: sin infecciones oportunistas). Actualmente se recomienda el uso de triterapia siempre, sin embargo, no existe duda que con menos de 350 CD4+ igualmente debe iniciarla. Además, bajo 200 CD4+ por mm3 debe iniciar la profilaxis para infecciones oportunistas, específicamente para Pneumocystis jiroveci, la que se hace con cotrimoxazol. No es necesario volver a pedir un Elisa, si el diagnóstico ya se hizo hace un año. La profilaxis con isoniazida, para la tuberculosis, está indicada solo si el PPD está positivo (mayor o igual a 5 mm, en el paciente VIH). La punción lumbar solo se indica si tiene clínica de meningitis o compromiso de conciencia, después de haber descartado la presencia de HTEC con el TAC.

Fuente: Infectología, cuestionario 9.4, P1

7. El tratamiento de elección de la toxoplasmosis cerebral en el paciente VIH es:

a. Metronidazol
b. Sulfadiazina + Pirimetamina
c. Benznidazol
d. Triterapia antirretroviral, ya que no tiene tratamiento específico
e. Quirúrgico

Respuesta correcta: b. Sulfadiazina + Pirimetamina

Explicación: La toxoplasmosis se trata con sulfadiazina más pirimetamina. El benznidazol se utiliza en el tratamiento de la enfermedad de Chagas (también el nifurtimox).

Fuente: Infectología, cuestionario 9.4, P15

8. Un paciente VIH presenta un cuadro de cefalea, seguido de compromiso de consciencia y parálisis del tercer nervio craneal izquierdo. Presenta además signos meníngeos, por lo que se realiza un TAC de cerebro, que descarta signos de hipertrofia endocraneana. Se procede a realizar una punción lumbar, que muestra elevación de las proteínas a 180 mg/dl, células de 740 por mm3, con 85% de mononucleares y glucorraquia de 20 mg/dl. El diagnóstico más probable es:

a. Meningitis bacteriana aguda
b. Meningitis herpética
c. Toxoplasmosis cerebral
d. Leucomalacia multifocal progresiva
e. Tuberculosis meníngea

Respuesta correcta: e. Tuberculosis meníngea

Explicación: Por tener predominio mononuclear, con glucosa baja, es una TBC meníngea. Sin embargo, en un paciente VIH también puede ser un criptococosis meníngea, aunque suele tener menos de 100 células (en este caso no está en las alternativas).

Fuente: Infectología, cuestionario 9.5, P2

9. Un paciente es diagnosticado de VIH, mediante un Elisa y Western Blot. Se solicitan linfocitos CD4, los que resultan en 150 por mm3. El paciente ha presentado 4 episodios de sinusitis en el último año, todos los que han respondido a tratamiento antibiótico oral. Actualmente se encuentra asintomático. La conducta más adecuada es:

a. Iniciar triterapia y profilaxis primaria para Pneumocystis
b. Solicitar PCR para VIH
c. Iniciar fluconazol oral
d. Iniciar triterapia y solicitar IgM para CMV.
e. Observar evolución

Respuesta correcta: a. Iniciar triterapia y profilaxis primaria para Pneumocystis

Explicación: Tiene VIH en etapa 3B (3: menos de 200 CD4+ por mm3; B: infecciones bacterianas no invasivas). Por tener menos de 350 CD4 tiene indicación de triterapia (aunque actualmente se recomienda dejar TAR a todos). Además, por tener menos de 200 CD4, tiene indicación de cotrimoxazol como profilaxis de Pneumocystis jiroveci.

Fuente: Infectología, cuestionario 9.5, P7

10. Un paciente diagnosticado de VIH, presenta un cuadro de tos, con expectoración, asociado a malestar general, de 2 semanas de evolución, que ha ido empeorando, hasta presenta disnea de pequeños esfuerzos. Al examen físico se aprecia taquipneico y se auscultan crepitaciones y sibilancias en ambos campos pulmonares. Se solicita una radiografía de tórax, que muestra relleno alveolointersticial bilateral, mayor en las bases. Se confirma la presencia de Pneumocystis jiroveci. El tratamiento más adecuado es:

a. Metronidazol
b. Cotrimoxazol
c. Anfotericina B
d. Albendazol
e. Fluconazol

Respuesta correcta: b. Cotrimoxazol

Explicación: El Pneumocystis jiroveci se trata con Cotrimoxazol. Además, recibe corticoides si hay hipoxemia. La dapsona, la clindamicina, la pentamidina y la pirimetamina son alternativas en el paciente alérgico.

Fuente: Infectología, cuestionario 9.5, P10

11. Un paciente VIH, sin terapia antirretroviral presenta un cuadro de cefalea, seguido de desorientación. Al examen físico se constata rigidez de nuca y signo de Brudzinsky. Por ello se realiza un TAC de cerebro, que resulta normal y no muestra signos de hipertrofia endocraneana, por lo que se procede a realizar una punción lumbar, que muestra elevación de las proteínas a 80 mg/dl, células de 40 por mm3, 90% de mononucleares y glucorraquia de 20 mg/dl. El diagnóstico más probable es:

a. Meningitis bacteriana
b. Meningitis herpética

c. Toxoplasmosis cerebral
d. Leucomalacia multifocal progresiva
e. Criptococosis meníngea

Respuesta correcta: e. Criptococosis meníngea

Explicación: La criptococosis se presenta como una meningitis subaguda, con glucosa baja y pleocitosis (elevación de las células) mononuclear. Puede ser igual a la TBC meníngea, por lo que siempre se debe confirmar con la tinción de tinta china. La TBC meníngea suele tener mayor pleocitosis (elevación de las células del LCR) y mayor compromiso de nervios craneales.

Fuente: Infectología, cuestionario 9.6, P2

12. Un paciente con promiscuidad sexual acude a control médico, donde se le realiza un Elisa para VIH, el que resulta positivo. Se repite el examen y nuevamente resulta positivo. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

a. Iniciar triterapia de inmediato
b. Confirmar con PCR para VIH
c. Solicitar antígenos virales, como la proteína p24
d. Solicitar un Western Blot para VIH y recuento de linfocitos T helper (CD4+)
e. Solicitar nuevo Elisa en 3 meses, por probable falso positivo

Respuesta correcta: d. Solicitar un Western Blot para VIH y recuento de linfocitos T helper (CD4+)

Explicación: Luego de 2 elisas positivos para VIH, se debe confirmar el diagnóstico con Western Blot. Además, los niveles de CD4 permiten saber el estado inmune para decidir el inicio de profilaxis de infecciones oportunistas. La guía chilena aún mantiene la recomendación de solicitar 2 Elisas y confirmar con un Western blot, ya que tiene elevadísima sensibilidad y especificidad para la infección crónica por VIH. Sin embargo, puede fallar en la infección aguda, ya que solo mide anticuerpos. Por eso, algunas recomendaciones nacionales e internacionales sugieren usar un examen inicial que mida antígenos y anticuerpos de manera simultánea (ej. inmunoensayo antígeno/anticuerpo de cuarta generación para VIH).

Fuente: Infectología, cuestionario 9.6, P7

13. Un paciente consulta porque recientemente mantuvo relaciones sexuales de riesgo y teme haberse contagiado de VIH. Tiene un Elisa VIH, que se realizó una semana después de dichas relaciones, el que está negativo. La conducta más adecuada es:

a. Solicitar un Western Blot para VIH
b. Descartar el diagnóstico de VIH y dar de alta
c. Repetir el Elisa en 6 semanas
d. Iniciar zidovudina oral
e. Iniciar triterapia antirretroviral oral

Respuesta correcta: c. Repetir el Elisa en 6 semanas

Explicación: Si se hubiese contagiado de VIH, está aún en el periodo de ventana, por lo que el Elisa puede ser un falso positivo. Por tanto, se debe repetir en 6 semanas, que es lo que dura el periodo de ventana (hasta 3 meses). La otra opción es medir carga viral o solicitar una PCR, ya que miden directamente el virus y positivizan luego de 7 a 10 días. Si hubiese consultad dentro de las primeras 72 horas, podría haber tomado triterapia como profilaxis.

Fuente: Infectología, cuestionario 9.7, P1

14. Una mujer cursando un embarazo de 10 semanas de edad gestacional, se realiza un test Elisa para VIH, que resulta positivo, por lo que se realiza un Western Blot, que también resulta positivo. Está completamente asintomática y su recuento de linfocitos CD4 es 1.200 por mm3. La conducta más adecuada es:

a. Observar evolución hasta el momento del parto, el que debe ser por cesárea y durante el cual debe recibir zidovudina por vía endovenosa
b. Iniciar triterapia a las 20 semanas, administrar zidovudina endovenosa durante el parto, y realizar cesárea, a menos que su carga viral sea indetectable
c. Iniciar efavirenz de inmediato y realizar cesárea al momento del parto
d. Iniciar zidovudina de inmediato y realizar cesárea al momento del parto
e. Iniciar triterapia de inmediato y realizar cesárea al momento del parto

Respuesta correcta: b. Iniciar triterapia a las 20 semanas, administrar zidovudina endovenosa durante el parto, y realizar cesárea, a menos que su carga viral sea indetectable

Explicación: La profilaxis de transmisión vertical del VIH se hace con 5 medidas: 1. Triterapia que inicia a las 20-24 semanas (16 semanas si es que la carga viral es mayor a 100.000 copias). 2. Se debe dar zidovudina en el parto. 3. Debe hacerse cesárea, a menos que la carga viral sea menor a 1.000 copias por mm3. 4. Debe prohibirse la lactancia materna y 5. Debe darse triterapia al recién nacido. De todo lo mencionado, lo más importante es la triterapia en el embarazo. De la triterapia hay algunos medicamentos que están contraindicados en el embarazo, como el efavirenz y la nevirapina. El esquema de antivirales (inicio, selección de fármacos, etc.) varía según el país. En Chile existe una guía Minsal que regula esto con detalle.

Fuente: Infectología, cuestionario 9.7, P2

15. ¿Cuál de los siguientes pacientes NO debe recibir triterapia antirretroviral?

a. Paciente VIH asintomático, con carga viral de 100.000 copias por mm3
b. Paciente VIH asintomático, con CD4+ de 300 por mm3
c. Paciente VIH con 2 infecciones neumocócicas en el último año
d. Paciente sano con accidente cortopunzante con un paciente con conductas de riesgo para VIH, que no se ha realizado nunca un Elisa
e. Paciente con Elisa VIH positivo y Western Blot negativo

Respuesta correcta: e. Paciente con Elisa VIH positivo y Western Blot negativo

Explicación: Según la OMS, todos los pacientes con VIH deben tratarse con terapia antirretroviral (TAR). El Minsal aún mantiene la indicación en la etapa B (infecciones no definitorias de SIDA) y en CD4 menores a 350, pero, en la práctica, todos los pacientes VIH(+) se les ofrece la TAR y generalmente la reciben. La opción E no tiene VIH, ya que el Western Blot descartó el diagnóstico de VIH y el Elisa era un falso positivo. *Si bien se le suele llamar "triterapia", no siempre usa 3 fármacos, por lo que el término más correcto es simplemente "terapia antirretroviral" (TAR).

Fuente: Infectología, cuestionario 9.7, P3

16. ¿Qué examen es el más adecuado para determinar el inicio de profilaxis para Pneumocystis jirovecii en un paciente con VIH?

a. Carga viral
b. Recuento de linfocitos CD4+
c. LDH plasmática

d. Inmunofluorescencia de expectoración
e. Serología para Pneumocystis

Respuesta correcta: b. Recuento de linfocitos CD4+

Explicación: La profilaxis de infecciones oportunistas se decide según el recuento de CD4. Bajo 200 por mm3 se indica profilaxis para Pneumocystis. Bajo 100, para Toxoplasma y criptococo. Bajo 50, para MAC (Mycobacterium avium complex) y CMV (citomegalovirus).

Fuente: Infectología, cuestionario 9.7, P4

17. Un paciente, diagnosticado de VIH, sin tratamiento antirretroviral, consulta por disminución de su agudeza visual, de rápida evolución, bilateral, sin dolor. Su último recuento de linfocitos CD4, fue realizado hace más de dos años y era de 200 células por mm3. El agente más probable es:

a. Virus herpes 8
b. Virus JC
c. Virus herpes simplex
d. Toxoplasma gondii
e. Citomegalovirus

Respuesta correcta: e. Citomegalovirus

Explicación: La coriorretinitis por CMV es la causa más frecuente de ceguera en el paciente VIH y se diagnostica simplemente con el fondo de ojo. El tratamiento se realiza con antivirales (ganciclovir) vía oral y, en casos muy graves, también se indica intraocular. Además, es fundamental iniciar la TAR cuanto antes.

Fuente: Infectología, cuestionario 9.7, P5

18. Un paciente diagnosticado de VIH, consulta por disfagia. Al examen físico se aprecia algorra en la cavidad oral y su examen abdominal es normal. La etiología más probable de su disfagia es:

a. Esofagitis por Candida albicans
b. Esofagitis por Citomegalovirus
c. Esofagitis por Mycobacterium avium complex
d. Linfoma MALT esofágico
e. Sarcoma de Kaposi esofágico

Respuesta correcta: a. Esofagitis por Candida albicans

Explicación: La causa más frecuente de disfagia en el paciente VIH es la candidiasis esofágica. Y es más frecuente aún, si paralelamente tiene candidiasis oral. Las otras causas son la esofagitis por CMV y la esofagitis herpética. - El diagnóstico de la candidiasis esofágica se realiza con endoscopía y biopsia. Sin embargo, cuando hay altísima sospecha (ej. candidiasis orofaríngea asociada), se realiza una prueba terapéutica con fluconazol por 7 días, debiendo mejorar. Si mejora, se completan 14-21 días. Si no mejora, se realiza la endoscopía.

Fuente: Infectología, cuestionario 9.7, P6

19. Un paciente presenta un cuadro de malestar general, odinofagia y fiebre, asociado a aparición de un exantema rosado, tenue, generalizado. Refiere haber tenido relaciones sexuales de riesgo hace un mes. ¿Qué examen es más adecuado para este paciente?

a. Elisa VIH
b. Western Blot VIH

c. PCR VIH
d. Recuento de linfocitos CD4 positivo
e. IgM VIH

Respuesta correcta: c. PCR VIH

Explicación: Tiene un síndrome retroviral agudo, es decir, una infección aguda por VIH, la que está en periodo de ventana, por lo que de elección se debe medir directamente el virus, mediante PCR o antígenos virales (ej. Antígeno P24). Tanto Elisa, como Western Blot resultan negativos en el periodo de ventana, ya que miden anticuerpos.

Fuente: Infectología, cuestionario 9.7, P7

20. Un paciente VIH positivo, sin triterapia, consulta por convulsiones autolimitadas. Al examen físico se constata hemiparesia derecha. El diagnóstico más probable es:

a. Leucomalacia multifocal progresiva
b. Toxoplasmosis
c. Meningitis criptocócica
d. Encefalitis por VIH
e. Meningitis herpética

Respuesta correcta: b. Toxoplasmosis

Explicación: La primera causa de convulsiones en el paciente VIH es la toxoplasmosis, la que produce lesiones focales, por lo que puede tener además signos focales (hemiparesia en este caso). Si, en cambio, tuviese signos meníngeos, lo más probable sería una criptococosis meníngea. Otras causas, incluyen: linfoma, meningitis tuberculosa, criptococoma, leucomalacia multifocal progresiva.

Fuente: Infectología, cuestionario 9.7, P8

21. Durante una cirugía traumatológica, de un paciente VIH, salta sangre dentro del ojo de un interno. ¿Cuál es la conducta para con este interno?

a. Observar evolución, sin necesidad de realizar exámenes
b. Observar evolución, solicitándole elisas seriados para VIH
c. Iniciar zidovudina oral, sin necesidad de realizar exámenes
d. Iniciar zidovudina oral, solicitándole elisas seriados para VIH
e. Iniciar triterapia oral, solicitándole elisas seriados para VIH

Respuesta correcta: e. Iniciar triterapia oral, solicitándole elisas seriados para VIH

Explicación: Tanto si el paciente tiene Elisa VIH positivo, como si no se ha realizado exámenes, la conducta en un accidente cortopunzante (y también en el contacto con fluidos de alto riesgo, como en este caso), es iniciar la terapia antirretroviral profiláctica. Solo se observa, cuando el paciente tiene negativo el Elisa.

Fuente: Infectología, cuestionario 9.7, P9

22. Identifique la asociación INCORRECTA entre la infección oportunista y su tratamiento:

a. Neumonía por Pneumocystis jiroveci – Sulfametoxazol + trimetoprim
b. Toxoplasmosis cerebral – Primetamina + sulfadiazina
c. Candidiasis esofágica – Fluconazol oral
d. Coriorretinitis por citomegalovirus – Ganciclovir
e. Criptosporidiasis intestinal – Albendazol

Respuesta correcta: e. Criptosporidiasis intestinal – Albendazol

Explicación: El criptosporidium no tiene tratamiento, sino simplemente mejorar el estado inmune, con la triterapia. En los casos en que no responde o que tiene otra causa no tratable de inmunodepresión, se puede usar la nitazoxanida. - El albendazol sí sirve pare el microsporidium. Las demás opciones se tratan de primera línea, con los fármacos que ahí aparecen.

Fuente: Infectología, cuestionario 9.7, P10

23. Un paciente VIH, diagnosticado hace 2 años, asintomático y con controles regulares, presenta un último control de linfocitos CD4(+), que resulta 150 por mm3. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

a. Iniciar triterapia antirretroviral y profilaxis con cotrimoxazol
b. Iniciar triterapia antirretroviral y profilaxis con cotrimoxazol, fluconazol y azitromicina
c. Iniciar profilaxis con cotrimoxazol
d. Iniciar profilaxis con cotrimoxazol, fluconazol y azitromicina
e. Iniciar triterapia antirretroviral

Respuesta correcta: a. Iniciar triterapia antirretroviral y profilaxis con cotrimoxazol

Explicación: Tiene VIH, por lo que debe iniciar trterapia (según la OMS), además tiene menos de 350 CD4, por lo que también debe iniciar triterapia (según el Minsal). Además tiene menos de 200 CD4, por lo que debe iniciar profilaxis para Pneumocystis, con cotrimoxazol. - No tiene menos de 50 CD4/mm3, por lo que no requiere profilaxis con azitromicina (para el MAC: Mycobacterum avium complex). - Bajo 100 CD4/mm3 requiere profilaxis para toxoplasma, pero suele ser la misma que para el Pneumocystis (la única excepción son los alérgicos a los fármacos que cubren ambas patologías, como el cotrimoxazol).

Fuente: Infectología, cuestionario 9.7, P11

Tuberculosis (7)

24. Una paciente de 35 años es diagnosticada de tuberculosis pulmonar, mediante PCR para tuberculosis y baciloscopías. Iniciar tratamiento con 4 fármacos. Vive con su esposo y sus 2 hijos de 7 y 9 años, todos los cuales se encuentran asintomáticos y están vacunados con la vacuna BCG. Tanto los niños como el marido tienen radiografía de tórax normal, PPD menor a 10 mm y baciloscopías negativas. ¿Cuál es la conducta respecto de ellos?

a. Iniciar profilaxis con isoniacida a todos
b. Iniciar profilaxis con isoniacida al marido y con 4 fármacos (rifampicina, isoniazida, etambutol y pirazinamida) a los niños
c. Iniciar profilaxis con 4 fármacos (rifampicina, isoniazida, etambutol y pirazinamida) a todos
d. Iniciar profilaxis con isoniacida solo a los niños
e. Educar y controlar con nuevos exámenes en 3 meses o antes, si inician síntomas, sin necesidad de fármacos por ahora

Respuesta correcta: d. Iniciar profilaxis con isoniacida solo a los niños

Explicación: Los contactos de pacientes tuberculosos bacilíferos se deben estudiar con completa anamnesis y examen físico, PPD o quantiferón-TB, baciloscopías más cultivo de Koch y radiografía de tórax. Se tratarán como caso de RBC, con 4 fármacos los que tengan baciloscopías o cultivos positivos y también los menores de 15 años con RxTx alterada. Se tratarán solo con isoniacida (tratamiento de la infección latente o también llamado “profilaxis”) en todos los menores de 15 años (por 3 a 6 meses, dependiendo del control a los 3 meses), independiente del PPD o quantiferón inicial; a los 3 meses se

repite (en niños, si sigue negativo, se suspende la isoniazida). Si positiviza, se deja por 6 meses. También se deja isoniacida por 6 meses a los adultos con PPD o quantiferón-TB positivos. 1. Demencia / Delirium

Fuente: Endocrinología y diabetes, cuestionario 7.8, P10

25. Un paciente de 80 años es diagnosticado de tuberculosis pulmonar bacilífera, por lo que inicia tratamiento con 4 fármacos. ¿Qué examen es más adecuado para el seguimiento de este paciente?

a. PPD
b. Baciloscopías y cultivo para mycobacterias
c. Radiografía de tórax
d. PCR para TBC
e. Pruebas hepáticas

Respuesta correcta: b. Baciloscopías y cultivo para mycobacterias

Explicación: El tratamiento de la TBC se sigue con baciloscopías y, además, se pide un cultivo al 4° mes (si está positivo se considera un fracaso). Lo más importante es el cultivo al cuarto mes, ya que es lo que define al fracaso y cambia conducta, pero, el examen de seguimiento propiamente tal son las baciloscopías mensuales., - Si las baciloscopías no negativizan al 4° mes o si negativizan, pero luego vuelven a positivizar, también se sospecha un fracaso al tratamiento, aunque su confirmación requiere del cultivo para mycobacterias. - El cultivo muestra, además, el patrón de resistencia, de manera de adaptar el tratamiento antibiótico.

Fuente: Infectología, cuestionario 9.1, P16

26. Un paciente de 40 años, diagnosticado de tuberculosis pulmonar bacilífera, abandona el tratamiento antibiótico, habiendo completado sólo 4 meses de tratamiento. Usted lo recibe 3 semanas después y está asintomático, sin alteraciones en su examen físico y con baciloscopía negativa. La conducta más adecuada es:

a. Solicitar PPD y radiografía de tórax
b. Solicitar cultivo de Koch y derivar a especialista para iniciar tratamiento secundario
c. Observar evolución
d. Solicitar broncoscopía
e. Retomar el tratamiento donde lo dejó, sin necesidad de exámenes

Respuesta correcta: e. Retomar el tratamiento donde lo dejó, sin necesidad de exámenes

Explicación: Sobre la discontinuation del tratamiento anti TBC es importante saber lo siguiente: 1. Importa más el número de dosis recibidas en total, que la continuidad estricta del tratamiento. 2. Las discontinuaciones breves son menos graves que las prolongadas. 3. Es peor suspender el tratamiento al inicio, en la fase diaria, que en la trisemanal. En este caso, dado que tiene menos de 4 semanas de haber suspendido el tratamiento, aún no cumple el diagnóstico de abandono. Por tanto, se debe retomar el tratamiento donde lo dejó. - Si hubiese llevado más de 4 semanas, lo correcto sería reiniciar el tratamiento desde el comienzo (para la fase diaria, algunas recomendaciones internacionales fijan en 2 semanas el plazo máximo para retomarlo). Además, habría que pedir un cultivo con antibiograma. - Si hubiese pasado mucho tiempo (ej. 12 meses) y pareciera estar curado (clínica negativa y baciloscopías o PCR negativa para TBC), se podría asumir la curación, sin necesidad de dar más fármacos.

Fuente: Infectología, cuestionario 9.1, P19

27. Un paciente inicia tratamiento antituberculoso, por una tuberculosis pulmonar bacilífera. Usted lo controla cuatro meses después con una baciloscopía, la que resulta positiva. Al revisar las baciloscopías de

los meses previos, usted nota que todas han estado positivas. Él refiere buena adherencia al tratamiento y mejoría sintomática. La conducta más adecuada es:

a. Solicitar nueva radiografía de tórax
b. Solicitar PPD
c. Mantener el tratamiento y controlar en un mes con nueva baciloscopía
d. Realizar biopsias pleurales
e. Solicitar cultivo para mycobacterias y derivar a especialista por fracaso del tratamiento

Respuesta correcta: e. Solicitar cultivo para mycobacterias y derivar a especialista por fracaso del tratamiento

Explicación: La sospecha diagnóstica es un fracaso a tratamiento, dado que las baciloscopías no han negativizado al cuarto mes. Sin embargo, en estricto rigor, el diagnóstico de fracaso requiere un cultivo positivo a partir del cuarto mes, pero como el cultivo para mycobacterias demora en dar un resultado, por ahora lo más prudente es derivarlo al especialista, para que evalúe el inicio de tratamiento secundario, hasta contar con el resultado del cultivo y del antibiograma.

Fuente: Infectología, cuestionario 9.3, P8

28. Un paciente de 60 años, indigente, es diagnosticado de tuberculosis pulmonar bacilífera. Inicia tratamiento con isoniazida, rifampicina, pirazinamida y etambutol, el que recibe por 2 meses. Posteriormente no acude a los siguientes controles, ni continúa el tratamiento. Usted lo recibe 2 meses más tarde, asintomático, sin alteraciones evidentes. Se solicita baciloscopía, que resulta positiva. La conducta más adecuada es:

a. Dar de alta
b. Reiniciar el tratamiento desde el inicio
c. Derivar para inicio de tratamiento secundario, con al menos 5 fármacos
d. Continuar el tratamiento con isoniazida y rifampicina por 4 meses más
e. Solicitar cultivo para Mycobacterias y decidir conducta según resultado

Respuesta correcta: b. Reiniciar el tratamiento desde el inicio

Explicación: Tiene un abandono de tratamiento (discontinuación del tratamiento), ya que lleva más de 4 semanas; por tanto, se debe iniciar el tratamiento desde el comienzo. Si hubiese discontinuado por menos de 4 semanas, lo correcto sería simplemente continuar el tratamiento.

Fuente: Infectología, cuestionario 9.3, P18

29. Un paciente de 60 años, indigente, es diagnosticado de tuberculosis pulmonar, por lo que inicia el tratamiento habitual, controlándose con baciloscopías mensuales, las que resultan: Mes 1: positiva, mes 2: negativa, mes 3: negativa, mes 4: positiva. Usted lo atiende al finalizar el cuarto mes, en la fase bisemanal (rifampicina + isoniazida), con el resultado de la baciloscopía. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

a. Mantener el tratamiento y controlar con nuevas baciloscopías y el resultado del cultivo de Koch
b. Reiniciar el tratamiento en fase diaria con 4 fármacos
c. Solicitar PCR para tuberculosis
d. Derivar a especialista, para inicio de tratamiento secundario, con 4 fármacos
e. Solicitar PPD y radiografía de tórax y decidir conducta según resultados

Respuesta correcta: a. Mantener el tratamiento y controlar con nuevas baciloscopías y el resultado del cultivo de Koch

Explicación: El fracaso del tratamiento de la tuberculosis se diagnostica con el cultivo para Mycobacterias, no solo con la baciloscopía, sin embargo, si se mantienen positivas las BK hasta el cuarto mes, o si aparecen 2 baciloscopías positivas seguidas, se debe sospechar fracaso y mientras el cultivo está pendiente, se inicia tratamiento secundario. En este caso solo tiene una BK positiva, por lo que lo más indicado es mantener el tratamiento y esperar el resultado del cultivo, ya que es probable que solo sea una eliminación esporádica de bacilo muerto. Las baciloscopías no son capaces de diferenciar las micobacterias vivas de las muertas, en cambio, el cultivo sí lo hace.

Fuente: Infectología, cuestionario 9.5, P8

30. Un paciente de 60 años, indigente, es diagnosticado de tuberculosis pulmonar, por lo que inicia el tratamiento habitual, sin embargo, deja de ir a los controles y por tanto, deja de recibir el tratamiento, luego de 2 meses (al haber completado la fase diaria). Usted lo recibe 2 años después, asintomático. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

a. Solicitar baciloscopías y decidir conducta según resultados
b. Solicitar PPD y radiografía de tórax y decidir conducta según hallazgos
c. Continuar el tratamiento, con la fase bisemanal
d. Reiniciar el tratamiento, desde la fase diaria
e. Observar evolución, sin necesidad de exámenes, ni fármacos

Respuesta correcta: a. Solicitar baciloscopías y decidir conducta según resultados

Explicación: Lo más importante frente a un abandono (Se define como 4 semanas sin tratamiento) es reiniciar el tratamiento desde cero. En cambio, si llevara menos de 4 semanas, se puede retomar en donde lo dejó, completando las dosis faltantes. Sin embargo, cuando ha pasado mucho tiempo (más de un año) y alcanzó a recibir una parte importante del tratamiento (la fase diaria contiene la mayor parte de las dosis de fármacos), es posible que se haya curado, en especial si está asintomático, por lo que lo correcto es solicitar exámenes en busca de la infección (baciloscopías o PCR para TBC más cultivo): - Si resultan negativos: está curado. - Si resultan positivos: se deberá reiniciar el tratamiento desde cero y, además, se deberá pedir antibiograma, para identificar el perfil de resistencia de las micobacterias.

Fuente: Infectología, cuestionario 9.6, P8

Hepatitis virales (5)

31. Un paciente de 56 años, diagnosticado de hepatitis crónica, se realiza exámenes en busca de virus de la hepatitis. Obtiene los siguientes resultados: IgG-VHC(+), IgG- VHBs(+),IgG-VHBc(+), IgM-VHBc(-), Ag-VHBs(-). El diagnóstico más probable es:

a. Hepatitis B aguda
b. Hepatitis B crónica
c. Hepatitis B y C crónicas
d. Hepatitis C crónica
e. Hepatitis de otra causa

Respuesta correcta: d. Hepatitis C crónica

Explicación: Tiene positiva la IgG-VHC, por lo que tiene positividad de los anticuerpos totales anti-VHC, es decir, tiene hepatitis C (aunque hay que confirmarlo con PCR para VHC, ya que hay un 10% de falsos positivos). Dado que el antígeno de superficie para VHB está negativo, no tiene hepatitis B. Sin embargo, dado que tiene las IgG antisuperficie y anticore positivas, es un paciente que tuvo hepatitis B antes, pero que no cronificó y mejoró. * El tratamiento de la hepatitis C, actualmente se recomienda en todos los

pacientes con PCR positiva. Dentro de los antivirales actuales están el 1. glecaprevir + pibrentasvir, 2. ledipasvir + sofosbuvir y el 3. sofosbuvir más velpatasvir (no es necesario saberlos, pero sí saber que existe nuevos antivirales bastante mejores que la ribavirina y el interferón).

Fuente: Infectología, cuestionario 9.2, P13

32. Un paciente de 60 años, insuficiente renal crónico y diabético, debe iniciar hemodiálisis, por lo que se solicitan pruebas serológicas para virus hepatitis, con los siguientes resultados: Antígeno-VHBs(+), IgMVHBc(-),IgG-VHBc(+), IgM- VHBs(-),IgG-VHBs(-), IgG-VHC(+), IgM-VHA(-), IgG-VHA(+). EL diagnóstico más probable es:

a. Infección solo por VHA
b. Infección solo por VHB
c. Infección solo por VHC
d. Infección conjunta por VHB y VHC
e. Infección conjunta por VHA, VHB y VHC

Respuesta correcta: d. Infección conjunta por VHB y VHC

Explicación: El antígeno de superficie está positivo, así que tiene hepatitis B. Dado que la IgM anticore está negativa, no puede ser aguda, sino que es crónica. La IgG anti VHC está positiva, por lo que los anticuerpos totales contra el VHC están positivos, por lo que tiene hepatitis C (aunque hay que confirmarlo con PCR). Finalmente, la IgM anti- VHA está negativa, por lo que no tiene hepatitis A (la IgG VHA positiva indica que está vacunado o que tuvo y se curó).

Fuente: Infectología, cuestionario 9.4, P7

33. Usted atiende a un matrimonio, ya que él acaba de ser diagnosticado de hepatits B. Ella trae exámenes que descartan la infección, tanto actual, como previa, pero relata que mantienen actividad sexual con frecuencia y está asustada ante la posibilidad de enfermarse. ¿Cuál es la conducta más adecuada para con ella?

a. Tranquilizarla y explicarle que no hay riesgo de contagio
b. Explicarle que está contagiada, pero que recibiendo antivirales, tanto ella, como su marido no correrán mayor peligro
c. Vacunarla contra la hepatitis B
d. Administrar gamaglobulina específica anti-VHB
e. Explicar que la única forma de evitar el contagio es usando métodos de barrera como anticonceptivo (preservativo)

Respuesta correcta: c. Vacunarla contra la hepatitis B

Explicación: Es una pregunta discutible, ya que aunque la vacuna es la medida más adecuada, si ha habido una relación sexual reciente, además puede indicarse la IgG específica anti-VHB (su indicación más clara es el hijo de madre con VHB, en que recibe la vacuna y la inmunoglobulina). Además, hasta que haya desarrollado la inmunidad, no está de más usar los métodos de barrera.

Fuente: Infectología, cuestionario 9.4, P17

34. Un paciente se realiza serologíapara virus hepatotropos, con el siguiente resultado: Antígeno de superficie VHB (-), IgG VHBs (+), IgG VHBc (+), IgM VHBc (-), IgG VHC (-), IgM VHC (-). ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

a. Hepatitis B crónica
b. Hepatitis B aguda

c. Paciente sano, que tuvo hepatitis B y se recuperó
d. Hepatitis B y C crónicas
e. Hepatitis C

Respuesta correcta: c. Paciente sano, que tuvo hepatitis B y se recuperó

Explicación: Todos los anticuerpos contra la hepatitis C están negativos, por lo que no puede ser una hepatitis C. Tiene el antígeno de superficie negativo, por lo que no tiene hepatitis B. Tiene la IgM anticore negativa, por lo que no puede tener una hepatitis B aguda (en periodo de ventana podría tener el antígeno de superficie negativo). Tiene la IgG antisuperficie positiva, por lo que está protegido de la hepatitis B, ya sea porque está vacunado o porque ya se enfermó y luego sanó. Como la IgG anticore está positiva estuvo expuesto al virus y como ya sabemos que no cronificó (tiene el antígeno de superficie negativo), la única opción es que se enfermó y luego sanó.

Fuente: Infectología, cuestionario 9.5, P11

35. ¿Cuál de los siguientes patrones de marcadores virales es más sugerente de una Hepatitis B crónica?

a. Antígeno de superficie VHB (+), IgG anti VHBs (-), IgG anti VHBc (+), IgM anti VHBc (-)
b. Antígeno de superficie VHB (+), IgG anti VHBs (-), IgG anti VHBc (-), IgM anti VHBc (+)
c. Antígeno de superficie VHB (-), IgG anti VHBs (-), IgG anti VHBc (-), IgM anti VHBc (+)
d. Antígeno de superficie VHB (-), IgG anti VHBs (+), IgG anti VHBc (-), IgM anti VHBc (-)
e. Antígeno de superficie VHB (-), IgG anti VHBs (+), IgG anti VHBc (+), IgM anti VHBc (-)

Respuesta correcta: a. Antígeno de superficie VHB (+), IgG anti VHBs (-), IgG anti VHBc (+), IgM anti VHBc (-)

Explicación: A) Hepatitis B crónica; B) Hepatitis B aguda; C) Hepatitis B aguda en periodo de ventana; D) Vacunado; E) Paciente que tuvo hepatitis B, pero no cronificó y sanó.

Fuente: Infectología, cuestionario 9.6, P11

Infecciones de transmisión sexual (7)

36. Un paciente de 30 años, sexualmente activo, consulta por aparición de lesiones en la zona púbica, que iniciaron hace 3 meses, como una única lesión y que luego fueron apareciendo nuevas lesiones, las que se muestran a continuación (fuente imagen: elrincondelamedicinainterna.com). No ha tenido fiebre ni otros síntomas y las lesiones son indoloras, sin prurito. ¿Cuál es el agente causal más probable?

a. Virus papiloma humano, serotipos 16 y 18
b. Virus papiloma humano, serotipos 6 y 11
c. Virus herpes simplex tipo 1
d. Virus herpes simplex tipo 2
e. Virus pox

Respuesta correcta: e. Virus pox

Explicación: Son moluscos contagiosos, causados por el virus pox. En adultos, se considera una infección de transmisión sexual, por lo que deben solicitarse múltiples exámenes en busca de otra. Si bien son autolimitados, el tratamiento suele ser el curetaje o la aplicación de nitrógeno líquido.

Fuente: Endocrinología y diabetes, cuestionario 7.8, P8

37. Un paciente de 45 años, consulta en el policlínico de ETS por una lesión en el glande, ulcerada, de 6 mm de diámetro, indolora, de fondo limpio. Refiere haber tenido relaciones sexuales sin protección. El resto del examen físico es normal. La conducta más adecuada es:

a. Iniciar doxicilina oral
b. Iniciar aclicovir oral
c. Administrar penicilina benzatina intramuscular y realizar seguimiento con VDRL
d. Solicitar FTA-ABS
e. Iniciar tratamiento con penicilina sódica por vía I.V.

Respuesta correcta: c. Administrar penicilina benzatina intramuscular y realizar seguimiento con VDRL

Explicación: Tiene una sífilis primaria (chancro). El diagnóstico en esta etapa es clínico y no requiere confirmación con ningún examen, sino simplemente el tratamiento con penicilina benzatina y actualmente se recomienda 2,4 millones UI, intramuscular, por 1 o 2 veces (separadas por 7 días). De todos modos, se debe seguir con VDRL, para asegurarse que se mantenga negativo o bien que positivice y luego negativice, en señal de éxito del tratamiento. - En las demás etapas, por regla general, se pide un VDRL o RPR (pruebas no treponémicas) y luego se confirma con FTA-ABS o MHA-TP (pruebas treponémicas).

Fuente: Infectología, cuestionario 9.1, P15

38. ¿Cuál de los siguientes tratamientos es más adecuado para el tratamiento de una uretritis gonocócica?

a. Metronidazol 2 gramos V.O. por una vez
b. Ceftriaxona 1 gramo E.V. cada 12 horas por 7 días
c. Ceftriaxona 250 mg I.M. por una vez
d. Doxiciclina 100 mg V.O. cada 12 horas por 10 días
e. Penicilina benzatina 1,2 millones I.M. por una vez

Respuesta correcta: c. Ceftriaxona 250 mg I.M. por una vez

Explicación: De elección se indica ceftriaxona 250 mg I.M. por una sola vez. Como alternativas están el ciprofloxacino 500 mg V.O. por 1 vez o la azitromicina 2 g V.O. por una vez. Eso siempre, se debe cubrir Chlamydia con la doxiciclina por 10 días o con la azitromicina 1 gramo por una vez, aunque no salga en las opciones.

Fuente: Infectología, cuestionario 9.1, P20

39. Un paciente de 32 años consulta por disuria intensa. Refiere haber mantenido relaciones sexuales sin protección. Al examen físico se aprecia eritema y secreción uretral purulenta y se aprecia que la ropa interior del paciente está manchada con dicha secreción. Usted está en un centro, que no dispone de exámenes de laboratorio. ¿Cuál de las siguientes alternativas es válida para tratar empíricamente a este paciente?

a. Cefxtriaxona intramuscular en una dosis, más doxiciclina por 10 días
b. Clindamicina oral más amoxicilina por 10 días
c. Metronidazol oral en monodosis
d. Azitromicina por 10 días
e. Penicilina benzatina en una dosis más ceftriaxona en una dosis

Respuesta correcta: a. Cefxtriaxona intramuscular en una dosis, más doxiciclina por 10 días

Explicación: Tiene una uretritis a germen desconocido. Lo ideal es pedirle un Gram de secreción uretral, que tiene buena sensibilidad en hombres (90%). En las mujeres, en cambio, se estudian con PCR para gonococo o con cultivo de Thayer Martin. El tratamiento debe cubrir tanto gonococo, como Chlamydia trachomatis. Para el gonococo, de elección se usa la ceftriaxona 250 mg IM por una vez (las recomendaciones internacionales sugieren 500 mg de ceftriaxona, ya que tienen mayor tasa de resistencia que Chile). Como alternativas está el ciprofloxacino 500 mg VO por 1 vez o la azitromicina 2 gramos por una vez, aunque tienen mayor tasa de resistencia que la ceftriaxona. Para la Chlamydia, de elección se usa la doxiciclina 100 mg cada 12 horas por 10 días y como alternativa está la azitromicina 1 gramo por una vez. * Algo importante es que, si hubiese tenido un Gram que visualice al gonococo (cocácea Gram negativa), igual debería dejarse cobertura tanto para gonococo como para clamidia. Por tanto, la uretritis gonocócica y la uretritis a germen desconocido se tratan igual.

Fuente: Infectología, cuestionario 9.2, P12

40. Una paciente con promiscuidad sexual, se realiza exámenes de chequeo, entre los que destaca un VDRL, que resultó positivo. Se solicita MHA-TP el que resulta negativo. La explicación más razonable es que:

a. Tuvo un cuadro previo de sífilis, que fue adecuadamente tratado
b. Se trata de un falso positivo del VDRL
c. Presenta una coinfección entre sífilis y VIH
d. Presenta una sífilis latente tardía
e. Presenta una sífilis latente precoz

Respuesta correcta: b. Se trata de un falso positivo del VDRL

Explicación: El VDRL (junto con el RPR) es una prueba no treponémica, que se usa como screening de sífilis. Sin embargo, tiene una tasa no despreciable de falsos positivos, por lo que se debe confirmar con una prueba treponémica (FTA-ABS o MHA-TP). Si esta última está positiva, confirma. Si está negativa, se trataba de un falso positivo (como en este caso). Las siglas significan lo siguiente: * VDRL = Veneral Disease Reaserch Laboratory. * RPR = Reagina Plasmática Rápida. * FTA-ABS = Fluorescente Treponema Antígeno – Absorción * MHA-TP = Micro Hema Aglutinación – Treponema Pallidum Recordatorio: RPR(+) y FTA-ABS(+) = sífilis. RPR(+) y FTA-ABS(-) = falso positivo. RPR(-) y FTA-ABS(+) = tratado y sanado. RPR(-) y FTA-ABS(-) = no tiene sífilis (a menos que tenga un chancro o sífilis primaria, en que se debe tratar igual).

Fuente: Infectología, cuestionario 9.3, P12

41. Un paciente de 45 años, con promiscuidad sexual inicia disuria intensa, asociada a secreción uretral purulenta, que mancha sus calzoncillos. ¿Qué examen es más adecuado para realizar el diagnóstico?

a. VDRL y luego confirmar con una prueba treponémica
b. Cultivo de secreción uretral
c. Serología para gonorrea y Chamydia
d. Gram de secreción uretral
e. Hemograma y hemocultivo

Respuesta correcta: d. Gram de secreción uretral

Explicación: En los hombres, el estudio etiológico de la uretriris sigue siendo el Gram. En las mujeres en cambio, el Gram tiene baja sensibilidad, por lo que se debe usar otros estudios, como la PCR o el cultivo, según la fuente que se lea.

Fuente: Infectología, cuestionario 9.5, P9

42. Un paciente de 45 años, homosexual, sin pareja estable, presenta un cuadro de fiebre y malestar general, asociado a aparición de un exantema máculo-papular, que compromete la cara, tronco y extremidades, con compromiso de las palmas y las plantas. ¿Qué examen es más adecuado para realizar el diagnóstico?

a. VDRL y luego confirmar con una prueba treponémica
b. PCR parea VIH
c. Elisa para VIH
d. Gram de secreción uretral
e. Hemograma y hemocultivo

Respuesta correcta: a. VDRL y luego confirmar con una prueba treponémica

Explicación: Se sospecha una sífilis secundaria (por el exantema con compromiso del palpmas y plantas), la que se diagnostica con la clínica más una prueba no treponémica, como el VDRL (bastan esas dos cosas para tratarla). Sin embargo, igual se suele confirmar después con una prueba treponémica. Recordar que es la promiscuidad sexual y no la orientación sexual lo que aumenta el riesgo de infecciones de transmisión sexual. ¿Cuándo tratar una sífilis? - Primaria: basta la clínica. - Secundaria: clínica + prueba no treponémica positiva. - Latente: prueba no treponémica positiva más prueba treponémica positiva. - Embarazo: cualquier prueba no treponémica positiva, independiente de la dilución.

Fuente: Infectología, cuestionario 9.6, P9

Infecciones de piel, partes blandas y micosis (15)

43. Un niño presenta lesiones costrosas amarillentas alrededor de la boca y en las mejillas, que aparecieron hace 3 días, pero que han aumentado considerablemente de tamaño. El tratamiento antibiótico de elección es:

a. Amoxicilina
b. Azitromicina
c. Cloxacilina
d. Ciprofloxacino
e. Moxifloxacino

Respuesta correcta: c. Cloxacilina

Explicación: Es un impétigo vulgar, que suele ser tanto por S. aureus (agente más frecuente) como por S. pyogenes. Para cubrir a ambos, se debe usar cloxacilina, flucloxacilina o cefadroxilo (u otra cefalosporina de 1ra generación). También se puede tratar de manera tópica, con mupirocina o furazolidona, cuando son pocas lesiones. La amoxicilina y la azitromicina no cubren bien al S. aureus.

Fuente: Infectología, cuestionario 9.1, P3

44. Un niño de 7 años presenta un cuadro de rinorrea purulenta, de 7 días de evolución, a lo que luego se agrega eritema y dolor ocular derecho. Al examen físico se aprecia ligera proptosis, eritema periocular y oftalmoparesia del ojo derecho. La agudeza visual es normal. ¿Qué tratamiento antibiótico le parece más adecuado para este paciente?

a. Ceftriaxona más cloxacilina
b. Cloxacilina
c. Quinolona de segunda generación
d. Macrólido

e. Penicilina benzatina

Respuesta correcta: a. Ceftriaxona más cloxacilina

Explicación: Tiene una sinusitis complicada con una celulitis orbitaria (la proptosis y oftalmoparesia son clásicas de la orbitaria o postseptal). El tratamiento es controvertido, pero la recomendación más aceptada es cubrir neumococo (germen más frecuente, ya que proviene del foco sinusal), con ceftriaxona endovenosa; y además, cubrir al Estafilococo áureo, con cloxacilina endovenosa. * Si hay riesgo de SAMR, se debe dejar vancomicina, en lugar de cloxacilina. Además, dado el aumento de la frecuencia de SAMR, actualmente es razonable dejar siempre vancomicina, en lugar de cloxacilina, en todas las infecciones potencialmente graves, hasta estar seguros que no hay resistencia (ej. resultado del antibiograma). - En la celulitis preorbitaria (o preseptal), se recomienda el cefuroximo o la amoxicilina-clavulánico (que cubren a ambos)

Fuente: Infectología, cuestionario 9.1, P10

45. Un paciente de 45 años, con antecedente de patología periodontal, consulta por aumento de volumen cervical, doloroso a la palpación. Al examen físico se aprecia una adenopatía de gran tamaño (4 cm), dolorosa a la palpación y con eritema de la piel que la recubre. El tratamiento antibiótico más adecuado es:

a. Macrólidos
b. Ampicilina
c. Metronidazol
d. Amoxicilina más ácido clavulánico
e. Ciprofloxacino

Respuesta correcta: d. Amoxicilina más ácido clavulánico

Explicación: Tiene una adenitits supurada, que frecuentemente es causada por S. aureus y SGA (por lo que se puede tratar con cloxacilina, cefadroxilo o amoxicilina-clavulánico). Eso sí, cuando se asocia a enfermedad periodontal, además se deben cubrir los anaerobios de la boca, con amoxicilina-clavulánico. Si no responde en 2-3 días, se debe sospechar infección por SAMR u otra bacteria resistente. Para el enfrentamiento de las adenopatías cervicales en niños, sirve lo siguiente: - Bilaterales y agudas: virus respiratorios. - Bilaterales y subagudas: mononucleosis y CMV. - Unilateral y aguda infamatoria: bacteriana. - Unilateral y subaguda/crónica: Bartonella y Mycobacterias. * No olvidarse de la enfermedad de Kawasaki y examinar bien al paciente.

Fuente: Infectología, cuestionario 9.1, P13

46. Un paciente de 50 años, sin antecedentes de importancia, consulta por fiebre alta, malestar general y dolor en la extremidad inferior izquierda. Al examen físico se aprecia una zona eritematosa de 40 cm de largo en la cara interna del muslo izquierdo, con varias áreas violáceas y negruzcas, que es muy dolorosa. El tratamiento de la patología descrita es:

a. Cloxacilina + clindamicina por vía endovenosa
b. Cloxacilina endovenosa + debridación quirúrgica
c. Cefazolina endovenosa + debridación quirúrgica
d. Penicilina endovenosa
e. Penicilina + clindamicina endovenosa + debridación quirúrgica

Respuesta correcta: e. Penicilina + clindamicina endovenosa + debridación quirúrgica

Explicación: Tiene una fascitis necrosante o fasceítis necrotizante tipo II (monomicrobiana, clásica de inmunocompetentes). Es causada por Streptoccus pyogenes o Estreptococo grupo A (SGA). Se trata con antibióticos endovenosos más debridación quirúrgica. El antibiótico de elección para el SGA es la penicilina y en las infecciones graves (ej. shock tóxico o fasceítis), se recomienda agregar clindamicina. Por eso, en este caso, se debe dejar penicilina sódica más clindamicina endovenosa. El diagnóstico es clínico y se confirma con la exploración quirúrgica. La RMN puede servir para confirmarla, siempre que no retrase la cirugía. La fascitis necrosante tipo I (polimicrobiana) es característica de diabéticos, adultos mayores, pacientes postrados e inmunodeprimidos. También requiere de cirugía y antibióticos, pero de amplio espectro, que cubran Gram(+), Gram(-) y anaerobios (ej. Imipenem + vancomicina + clindamicina; ej.2 Ceftriaxona + clindamicina).

Fuente: Infectología, cuestionario 9.1, P14

47. Un lactante de 9 meses de edad presenta un cuadro de fiebre y aparición de un exantema generalizado, de un día de evolución, que inició como eritema, de predominio en los pliegues, el que luego fue seguido de aparición de múltiples bulas generalizadas, fáciles de romper. El tratamiento más adecuado es:

a. Penicilina endovenosa
b. Cloxacilina + clindamicina endovenosas
c. Vancomicina endovenosa
d. Ceftriaxona endovenosa
e. Aciclovir endovenoso

Respuesta correcta: b. Cloxacilina + clindamicina endovenosas

Explicación: Es un síndrome de piel escaldada estafilocócica. El diagnóstico es clínico y se trata con antibióticos antiestafilocócicos. La cloxacilina endovenosa o las cefalosporinas de primera generación (cefazolina) son de elección. Además se recomienda agregar clindamicina endovenosa, ya que teóricamente disminuye la producción de toxinas (en este caso la toxina exfoliativa o dermotoxina estafilocócica), aunque no hay evidencia clara sobre el uso de clindamicina. La vancomicina es una opción aceptable es la actualidad, dado el aumento de la prevalencia de SAMR. Sin embargo, dejaremos como correcta la cloxacilina + clindamicina, por ser lo habitualmente enseñado.

Fuente: Infectología, cuestionario 9.2, P4

48. El tratamiento de la tiña capitis en los niños se realiza con:

a. Terbinafina tópica
b. Clotrimazol tópico
c. Ketoconazol oral
d. Griseofulvina oral
e. Itraconazol endovenoso

Respuesta correcta: d. Griseofulvina oral

Explicación: La griseofulvina oral es el tratamiento de elección para la tiña capitis, causada por el Microsporum canis. Es mejor que la terbinafina para el microsporum. Es importante que el tratamiento debe ser oral, a diferencia de algunas otras tiñas. En el caso de la tiña tricofítica (menos frecuente), se puede usar tanto la griseofulvina como la terbinafina (esta última será una opción aceptable si es que se confirma que el agente es un Trichophyton.

Fuente: Infectología, cuestionario 9.2, P18

49. Un paciente consulta por fiebre y aparición de una zona roja en la pierna izquierda, caracterizada por una placa sensible, de 10 cm de diámetro mayor, de bordes claramente definidos. El tratamiento de elección es:

a. Clindamicina
b. Vancomicina
c. Penicilina
d. Macrólido
e. Ceftriaxona

Respuesta correcta: c. Penicilina

Explicación: El diagnóstico es una erisipela, dado los bordes bien definidos. Es causada por Streptococcus pyogenes (Grupo A), el que se trata de elección con penicilina G endovenosa. En alérgicos, de elección serán las cefalosporinas o, si están contraindicadas (ej. alergia a la penicilina mediada por IgE o severa), se usa la clindamicina. Si hubiese tenido bordes difusos o si quedara la duda, habría sido una celulitis, que se trata con cloxacilina o cefalosporinas (clindamicina en alérgicos). Eso sí, si se sospecha SAMR (ej. hospitalización reciente) o si está grave (séptico), actualmente se recomienda dejar directamente vancomicina u otro fármaco. - Si el paciente está bien y tiene una lesión pequeña, se puede indicar tratamiento oral. - Si, en cambio, está séptico, febril y decaído o con lesión de gran tamaño, se debe iniciar endovenoso. ¿Cómo matar a un Streptococcus pyogenes? Penicilina, amoxicilina, cloxacilina, flucloxacilina, cefalosporinas, clindamicina. ¿Cómo matar a un Staphilococcus aureus meticilino sensible? Cloxacilina, flucloxacilina, cefalosporinas, clindamicina. ¿Cómo matar a un Staphilococcus aureus meticilino resistente? Oral: Cotrimoxazol + rifampicina; Endovenoso: vancomicina, linezolid, daptomicina.

Fuente: Infectología, cuestionario 9.3, P4

50. Un paciente presenta una infección de una herida operatoria, por un Staphilococcus aureus, que el antibiograma resultó sensible a la meticilina. ¿Qué tratamiento es el más aconsejado?

a. Piperacilina
b. Cloxacilina
c. Ceftriaxona
d. Linezolid
e. Vancomicina

Respuesta correcta: b. Cloxacilina

Explicación: El SAMS (S. aureus meticilina sensible) se trata con cloxacilina, flucloxacilina, cefalosporinas de primera y segunda generación, amoxiclina + ácido clavulánico y clindamicina. El SAMR (S. aureus meticilina resistente) se trata con vancomicina y si no funciona, con linezolid o daptomicina.

Fuente: Infectología, cuestionario 9.3, P17

51. El tratamiento de elección de la onicomicosis es:

a. Anfotericina B endovenosa
b. Terbinafina tópica
c. Clotrimazol tópico
d. Fluconazol oral en monodosis
e. Terbinafina oral

Respuesta correcta: e. Terbinafina oral

Explicación: La onicomicosis se trata con medicamentos orales, de elección de terbinafina, ya que tiene excelente acción contra el Trichophytum rubrum y tiene baja toxicidad. - El fluconazol oral en monodosis se usa para las infecciones candidiásicas, ya que su efectividad para la onicomicosis suele ser solo de un 70-80% y tiene mayor toxicidad hepática, ya que requiere múltiples dosis. - La anfotericina B liposomal ha reemplazado a la anfotericina B simple, por ser menos tóxica (hepática y renal) y solo se usa en infecciones graves por hongos, como la criptococosis meníngea o las infecciones invasivas por aspergillus o mucor. También se usa en el embarazo, cuando no es posible usar los imidazoles, que son teratogénicos.

Fuente: Infectología, cuestionario 9.4, P3

52. Un paciente de 68 años consulta por fiebre y aparición de una lesión eritematosa en la cara. Al examen físico se aprecia una placa roja, caliente, de bordes claramente definidos, de un diámetro mayor de 6 cm, asociada a múltiples adenopatías cervicales ipsilaterales. El agente etiológico más probable es:

a. Staphilococcus aureus
b. Staphilococcus epidirmidis
c. Streptococcus pyogenes
d. Streptococcus pneumoniae
e. Anaerobios

Respuesta correcta: c. Streptococcus pyogenes

Explicación: Tiene una erisipela clásica (lesión eritematosa con bordes definidos), causada principalmente por S. pyogenes (Estreptococo betahemolítico grupo A).

Fuente: Infectología, cuestionario 9.4, P8

53. Un paciente de 45 años presenta una masa inflamatoria en la cara, que inició después de afeitarse. Al examen se constata una masa de 6cm de diámetro, eritematosa, con múltiples pústulas en su superficie, en relación a cada folículo piloso. La conducta más adecuada es:

a. Realizar drenaje aspirativo con jeringa
b. Iniciar antibióticos orales
c. Iniciar antibióticos endovenosos, sin necesidad de drenaje
d. Realizar biopsia con aguja y solicitar baciloscopías
e. Iniciar antibióticos endovenosos y realizar drenaje en pabellón

Respuesta correcta: e. Iniciar antibióticos endovenosos y realizar drenaje en pabellón

Explicación: El diagnóstico es un ántrax estafilocócico: infección de los folículos pilosos, que forman una masa inflamatoria (son como muchos furúnculos que confluyen). Se trata con cloxacilina o cefazolina endovenosa, más drenaje quirúrgico en pabellón.

Fuente: Infectología, cuestionario 9.4, P16

54. Un paciente diabético de 65 años consulta por un cuadro de malestar general, rinorrea purulenta y luego rápido deterioro del estado general, aparición de eritema en la cara y nariz, con dificultad para ver, proptosis del ojo derecho, y finalmente compromiso de consciencia. El agente etiológico más probable es:

a. Pseudomona aureginosa
b. Staphilococcus aureus
c. Streptococcus pneumoniae
d. Aspergillus

e. Mucor

Respuesta correcta: e. Mucor

Explicación: Tiene una mucormicosis clásica: diabético (o neutropénico) con una sinusitis de rápida instalación, muy agresiva (con proptosis, necrosis cutánea, invasión del cerebro). Se trata con anfotericina liposomal endovenosa, más resección quirúrgica de las áreas comprometidas (es muy deformante y generalmente letal, con tasas mayores al 50%). Existe la mucormicosis pulmonar, que es una neumonía necrotizante de rápida evolución, generalmente con hemoptisis, deterioro generalizado y letalidad de cerca de 90%. El diagnóstico se realiza con biopsia, pero lo principal es la sospecha clínica de las formas rino-orbito-cerebrales en la etapa inicial (nasosinusal), ya que permite actuar rápido y salvar al paciente.

Fuente: Infectología, cuestionario 9.4, P19

55. Un paciente de 65 años, sin antecedentes de importancia, presenta un cuadro de dolor en la pierna derecha, asociada a fiebre y eritema de la piel pretibial. Se plantea el diagnóstico de una osteomielitis aguda en la tibia derecha, la que se confirma con una resonancia magnética nuclear. La conducta más adecuada en este momento es:

a. Iniciar vancomicina endovenosa
b. Iniciar cloxacilina endovenosa
c. Iniciar ceftriaxona endovenosa
d. Realizar cirugía de inmediato e iniciar antibióticos una vez obtenido el resultado del cultivo de muestra ósea
e. Realizar cultivo por punción e iniciar antibióticos, una vez obtenido el resultado de dicho cultivo

Respuesta correcta: b. Iniciar cloxacilina endovenosa

Explicación: El manejo de la osteomielitis es distinto, según se trate de una osteomielitis hematógena (como en este caso, que no tiene una causa aparente) o se trate de una osteomielitis por contigüidad (ej. fractura expuesta, pie diabético). - La hematógena se trata con antibióticos endovenosos, ajustados por antibiograma y, si queda tejido infectado residual, se realiza debridamiento quirúrgico. - La por contigüidad se trata con debridamiento quirúrgico (amputación en los casos más graves), más antibióticos, ajustados por antibiograma. * Aunque el S. aureus sensible es el agente más frecuente, actualmente, mientras no se haya aislado el agente, se recomienda dejar cobertura para gram positivos, con cobertura para SAMR y para gram negativos. Ejemplo: Vancomicina + cefepime. Una vez se tiene el antibiograma, se ajusta el tratamiento.

Fuente: Infectología, cuestionario 9.5, P14

56. Un paciente de 50 años presenta fiebre y aparición de una lesión en el muslo izquierdo. Inicialmente era una placa eritematosa y algo dolorosa, de bordes difíciles de definir y de cerca de 10 cm de diámetro mayor. Se solicita un hemograma, que muestra leucocitosis, de predominio neutrofílico. El diagnóstico más probable es:

a. Erisipela
b. Ectima
c. Celulitis
d. Fasceítis necrotizante
e. Shock tóxico

Respuesta correcta: c. Celulitis

Explicación: Es una celulitis clásica, en especial por los "bordes difíciles de definir". Es causada por S. aureus y S. pyogenes, por lo que se trata con cloxacilina endovenosa. Si está séptico o muy grave, actualmente se recomienda agregar vancomicina, para cubrir SAMR.

Fuente: Infectología, cuestionario 9.5, P15

57. Un paciente de 50 años presenta fiebre y aparición de una lesión en el muslo izquierdo. Inicialmente era una placa eritematosa y dolorosa, de bordes fáciles de definir y de cerca de 10 cm de diámetro mayor, pero luego creció rápidamente en cosa de horas, hasta alcanzar los 30 cm y volverse muy dolorosa. Al examen físico se aprecian áreas violáceas y equimóticas, con otras negruzcas, en la lesión y el paciente se observa de aspecto séptico. El agente etiológico más probable es:

a. Pseudomona aureginosa
b. Staphilococcus aureus
c. Neisseria meningitidis
d. Staphilococcus epidermidis
e. Streptococcus pyogenes

Respuesta correcta: e. Streptococcus pyogenes

Explicación: Es una fasceítis necrotizante o fascitis necrosante (aunque inicialmente parecía una celulitis, pero luego aparecieron las zonas violácea, equimóticas y negras de la necrosis) tipo II (monobacteriana, sin enfermedades de base). El SGA o S. Pyogenes es la causa más frecuente. Se diagnostica con la clínica, aunque la RMN o ecografía pueden ayudar a precisar el diagnóstico. Eso sí, no deben retrasar la debridación quirúrgica. Se trata con cirugía más antibióticos endovenosos (penicilina + clindamicina en la tipo 2). La tipo 1 (polimicrobiana) se asocia a pie diabético, escaras y otras patologías de base. Se trata con debridación quirúrgica y antibióticos de amplio espectro.

Fuente: Infectología, cuestionario 9.6, P15

Meningitis, encefalitis y absceso cerebral (9)

58. Un niño de 5 años presenta una meningitis bacteriana aguda, a germen desconocido. El tratamiento empírico más adecuado es:

a. Ceftriaxona + cloxacilina + dexametasona
b. Penicilina + metronidazol + dexametasona
c. Ceftriaxona + vancomicina + dexametasona
d. Cefotaximo + ampicilina + dexametasona
e. Clindamicina + gentamicina + dexametasona

Respuesta correcta: c. Ceftriaxona + vancomicina + dexametasona

Explicación: El tratamiento empírico de las meningitis bacterianas agudas es con ceftriaxona o cefotaximo (cubren bien neumococo, meningococo, Haemophilus y E. coli K1, que son los microorganismos más frecuentes). * En pediatría, además, se recomienda agregar Vancomicina, ya que cubre al neumococo resistente a vancomicina. En adultos, actualmente, también se suele recomendar agregar vancomicina, ya que ha aumentado la prevalencia de resistencia y se trata de una infección muy grave. * Los corticoides se suelen indicar siempre (aunque solo han demostrado reducir las secuelas en niños con meningitis por neumococo o Haemophilus). * En las embarazadas y adultos mayores, se recomienda agregar ampicilina, para cubrir Listeria.

Fuente: Infectología, cuestionario 9.1, P9

59. Un paciente de 56 años, sin antecedentes de importancia, se realiza un TAC de cerebro, como parte del estudio de una migraña. Se aprecian dos imágenes compatibles con neurocisticercos, calcificados, de 3 mm de diámetro cada uno. La conducta más adecuada es:

a. Resolver quirúrgicamente de inmediato
b. Iniciar tratamiento con praziquantel por 6 semanas y realizar punción de los neurocisticercos con suero hipertónico
c. Iniciar tratamiento con nifurtimox
d. Iniciar anticonvulsivantes profilácticos
e. Observar evolución

Respuesta correcta: e. Observar evolución

Explicación: El tratamiento de la neurocisticercosis varía caso a caso. Sin embargo, la regla general es que si son asintomáticos e inactivos simplemente se observan. En este caso, se encontraron como hallazgo y están calcificados (inactivos), por lo que se deben observar. Si bien el antecedente de migraña podría dar a entender que el paciente está sintomático, la verdad es que la cefalea de un cisticerco grande, sería la de un síndrome de hipertensión endocraneana (cefalea matinal, con náuseas, vómitos y edema de papila) y no una migraña. Además, que son muy pequeños (solo milímetros), por lo que no explican los síntomas. - Si producen convulsiones, se agregan anticonvulsivanetes (ej. carbamazepina o fenitoína, que son anticonvulsivantes con acción en lesiones focales). - Si tiene síndrome de hipertensión endocraneana o compresión de alguna estructura, se deben operar. - Si están activos (descritos como "viables" o "en degeneración", se recomienda tratarlos con albendazol (más praziquantel, si son 3 o más lesiones) más corticoides. - Siempre se debe hacer fondo de ojo, en busca de cisticercosis ocular, que se trata con cirugía.

Fuente: Infectología, cuestionario 9.2, P6

60. El tratamiento antibiótico empírico de la meningitis bacteriana aguda durante el embarazo debe ser:

a. Ampicilina + metronidazol
b. Ceftriaxona + metronidazol
c. Ceftriaxona + vancomicina
d. Ceftriaxona + penicilina
e. Ampicilina + ceftriaxona + vancomicina

Respuesta correcta: e. Ampicilina + ceftriaxona + vancomicina

Explicación: La ceftriaxona cubre los gérmenes habituales de meningitis (Neumococo, meningococo y Haemophilus). Además, en el embarazo (al igual que en los adultos mayores) se debe cubrir Listeria monocytogenes, con ampicilina. Actualmente, dado el aumento de prevalencia de resistencia del neumococo a la penicilina, se recomienda agregar vancomicina al tratamiento (neumococo hace resistencia por mutaciones de las PBP, al igual que el SAMR).

Fuente: Infectología, cuestionario 9.2, P7

61. Una paciente de 91 años es diagnosticada de meningitis bacteriana aguda, a germen desconocido. El tratamiento antibiótico empírico recomendado es:

a. Ceftriaxona+ ampicilina + vancomicina
b. Gentamicina + ceftriaxona
c. Ceftazidima + amykacina
d. Clindamicina + vancomicina

e. Cloxacilina + metronidazol + cefotaximo

Respuesta correcta: a. Ceftriaxona+ ampicilina + vancomicina

Explicación: El tratamiento de elección de la meningitis bacteriana es la ceftriaxona (o el cefotaximo), ya que cubren neumococo, meningococo y Haemophilus. Sin embargo, en el adulto mayor (y en el embarazo), se debe agregar ampicilina, para cubrir Listeria. La vancomicina actualmente se recomienda en todas las edades, debido al aumento de resistencia a la penicilina por parte del neumococo.

Fuente: Infectología, cuestionario 9.3, P3

62. Un paciente de 20 años, presenta un cuadro sugerente de meningitis bacteriana aguda, por lo que se decide realizar una punción lumbar que da salida a un líquido cefalorraquídeo inflamatorio, turbio, con más de 1.000 células por mm3, con predominio polimorfonuclear. Además, se aprecian abundantes cocáceas Gram positivas, en disposición en cadenas cortas y diplos. El agente etiológico más probable es:

a. Neisseria meningitidis
b. Listeria monocytogenes
c. Haemophilus influenza
d. Neumococo
e. Estreptococo grupo A

Respuesta correcta: d. Neumococo

Explicación: El neumococo es la causa más frecuente de MBA (meningitis bacteriana aguda). Además, es un estreptococo (en cadenas): Streptococcus pneumoniae, aunque suele ser de cadenas muy cortas o simplemente diplococos. Neisseria meningitidis = diplococo Gram negativo Listeria monocytogenes = bacilo Gram positivo Haemophilus influenza = cocobacilo Gram negativo Estreptococo grupo A = coco Gram positivo, en cadenas largas. No es causa de MBA.

Fuente: Infectología, cuestionario 9.3, P15

63. Un paciente presenta un cuadro de fiebre y cefalea, de 5 días de evolución, a lo que se ha agregado imposibilidad para mover las extremidades izquierdas. Consulta en el servicio de urgencia por presentar además una convulsión tónicoclónica de 5 minutos. El diagnóstico más probable es:

a. Meningitis tuberculosa
b. Meningitis herpética
c. Meningitis bacteriana
d. Absceso cerebral
e. Encefalitis por virus de la rabia

Respuesta correcta: d. Absceso cerebral

Explicación: Si bien, puede ser más de una de las alternativas, tiene el cuadro clásico del absceso cerebral: cefalea, fiebre, signos focales y convulsiones (es el único con signos focales, en las opciones). El diagnóstico se realiza con una neuroimagen (RMN es mejor la TAC con contraste). El tratamiento es el drenaje por punción más antibióticos (ceftriaxona + metronidazol + vancomicina), para cubrir anaerobios (metronidazol); neumococo y gram negativos (ceftriaxona); neumococo resistente y estafilococo (vancomicina). - La meningitis TBC tiene un cuadro subagudo de cefalea, signos meníngeos y afectación de los nervios craneales oculomotores. - La meningitis herpética tiene un cuadro agudo de cefalea, fiebre, puede tener signos meníngeos, pero se caracteriza por desorientación, agresividad y también puede tener convulsiones. Las neuroimágenes suelen mostrar lesiones en los lóbulos temporales. - La meningitis bacteriana tiene cefalea, fiebre y signos meníngeos. - La rabia tiene desorientación, afectación motora,

dificultad para tragar y luego evoluciona a falla multiorgánica y muerte. En Chile no hay casos hace muchos años.

Fuente: Infectología, cuestionario 9.4, P11

64. El meningococo se observa en la tinción de Gram como:

a. Un cocobacilo gram negativo
b. Una cocácea gram negativa en diplos y unidades
c. Una cocácea gram positiva en racimo
d. Una cocácea gram positiva en cadenas largas
e. Una cocácea gram positiva en diplos y cadenas cortas

Respuesta correcta: b. Una cocácea gram negativa en diplos y unidades

Explicación: En una meningitis bacteriana, la tinción de Gram ayuda a identificar el agente: - Un cocobacilo gram negativo: Haemophilus. - Una cocácea gram negativa en diplos y unidades: Meningococo. - Una cocácea gram positiva en racimo: Staphilococcus aureus (en meningitios por TEC abierto o postneuroquirúrgicas). - Una cocácea gram positiva en cadenas largas: Estreptococos (ej. pyogenes o agalactiae). El S. agalactiae puede producir meningitis en recién nacido. El S. pyogenes no suele producir meningitis. - Una cocácea gram positiva en diplos y cadenas cortas: neumococo (Streptococcus pneumoniae).

Fuente: Infectología, cuestionario 9.4, P14

65. Un paciente de 22 años presenta un cuadro de malestar general y fiebre de 24 horas de evolución, lo que se agrega desorientación y compromiso de consciencia. Se realiza estudio, concluyéndose que padece de una meningitis meningocócica, por la cepa B, por lo que se inicia tratamiento. La conducta más adecuada con sus FAMILIARES, que viven con él, es:

a. Observar evolución
b. Indicarles ciprofloxacino en una dosis
c. Indicarles amoxicilina por 2 días
d. Indicarles azitromicina en una dosis
e. Indicarles ceftriaxona por 7 días

Respuesta correcta: b. Indicarles ciprofloxacino en una dosis

Explicación: La profilaxis de los contactos de meningococo se realiza con rifampicina por 2 días (600 mg c/12 horas; en niños: 10 mg/Kg c/12 horas). - Como alternativas está el ciprofloxacino v.o. 500 mg por 1 vez y la ceftriaxona i.m. 250-500 mg por 1 vez (en niños, la mitad de la dosis). Actualmente el tratamiento de elección es la ceftriaxona (más fácil de usar que la penicilina en altas dosis, que también es aceptable). En alérgicos, se pueden usar cloranfenicol, levofloxacino, imipenem o astreonam. El aislamiento de los casos se debe dejar por mínimo 24 horas después de haber iniciado el tratamiento antibiótico.

Fuente: Infectología, cuestionario 9.5, P12

66. Un paciente de 22 años presenta un cuadro de malestar general y fiebre de 24 horas de evolución, lo que se agrega desorientación y agresividad. Además, ha convulsionado en dos oportunidades. Se solicita un TAC de cerebro, que muestra una lesión en el lóbulo temporal izquierdo y una punción lumbar, que resulta hemorrágica. La conducta más adecuada es:

a. Iniciar ceftriaxona más vancomicina endovenosa y proseguir con el estudio
b. Iniciar corticoides endovenosos y proseguir con el estudio

c. Iniciar aciclovir endovenoso y proseguir con el estudio
d. Iniciar ceftriaxona más ampicilina endovenosa y proseguir con el estudio
e. Iniciar fármacos antituberculosos y proseguir con el estudio

Respuesta correcta: c. Iniciar aciclovir endovenoso y proseguir con el estudio

Explicación: Se sospecha una encefalitis herpética, tanto por la clínica: fiebre, cefalea y desorientación, como por la punción lumbar hemorrágica. La mera sospecha es indicación de aciclovir endovenoso. Se estudia con PCR para VHS en LCR.

Fuente: Infectología, cuestionario 9.6, P12

Infecciones urinarias (8)

67. El diagnóstico de infección del tracto urinario se establece cuando:

a. El urocultivo por orina de segundo chorro resulta positivo, con más de 1.000.000 de UFC por ml
b. El urocultivo por orina de segundo chorro resulta positivo, con más de 100.000 UFC por ml
c. El urocultivo por orina de segundo chorro resulta positivo, con más de 1.000 UFC por ml
d. El sedimento de orina muestra más de 10 leucocitos por campo
e. El sedimento de orina muestra más de 100 leucocitos por campo

Respuesta correcta: b. El urocultivo por orina de segundo chorro resulta positivo, con más de 100.000 UFC por ml

Explicación: El diagnóstico de ITU se hace mediante la clínica más el urocultivo positivo. Se considera positivo si es mayor a 100.000 UFC/mL en la orina de segundo chorro o en el recolector; mayor a 10.000 UFC/mL en la orina por sondeo y basta 1 UFC en la muestra obtenida por punción vesical. Eso sí, actualmente se acepta tratar directamente a las ITU baja, sin necesidad de tomar un urocultivo, siempre y cuando se trate de una paciente de sexo femenino con clínica característica de ITU baja y que responda al tratamiento. Por otro lado, algunos estudios han demostrado que pacientes con clínica de ITU u urocultivos positivos, pero con menos de 100.000 UFC/ml igual tienen alta probabilidad de tener ITU, por lo que se recomienda manejar caso a caso, ya sea tomando una nueva muestra por sondeo o bien indicando tratamiento antibiótico.

Fuente: Infectología, cuestionario 9.1, P2

68. ¿Cuál de los siguientes tratamientos es más adecuado para una pielonefritis aguda en el embarazo?

a. Nitrofurantoína oral
b. Clindamicina endovenosa
c. Ceftriaxona endovenosa
d. Macrólidos orales
e. Ciprofloxacino endovenoso

Respuesta correcta: c. Ceftriaxona endovenosa

Explicación: En el embarazo, la PNA se debe tratar con antibióticos endovenosos (a diferencia de las mujeres no embarazadas, que se tratan con antibióticos orales). En el embarazo, de elección, según la guía Minsal, se indican las cefalosporinas de primera (cefazolina) y, si hay resistencia, se usan las tercera generación (ceftriaxona). Sin embargo, actualmente, la mayoría de recomendaciones internacionales sugieren iniciar directamente la ceftriaxona. - Los aminoglicósidos, en especial la gentamicina, se pueden usar en el embarazo, pero solo en casos seleccionados (ej. alergia a cefalosporinas), ya que tienen algún riesgo para el feto. - La nitrofurantoína no se acumula bien a nivel renal (solo sirve en ITU baja y sí se

puede usar en el embarazo). - El ciprofloxacino no se debe indicar en el embarazo, salvo casos excepcionales.

Fuente: Infectología, cuestionario 9.1, P7

69. Una paciente de 38 años presenta disuria y polaquiuria de 2 días de evolución. No ha presentado fiebre ni otros síntomas. Se solicita un sedimento de orina, que muestra abundantes bacterias y 50 leucocitos por campo y un urocultivo, que está pendiente. La conducta más adecuada es:

a. Esperar el resultado del urocultivo, sin iniciar antibióticos por el momento
b. Iniciar ciprofloxacino 500 mg cada 12 horas por 3 días y controlar con el resultado del urocultivo
c. Iniciar ceftriaxona endovenosa 1 gramo al día y controlar con el resultado del urocultivo
d. Dar monodosis de nitrofurantoína y controlar con el resultado del urocultivo
e. Indicar metronidazol 500 mg cada 8 horas por 7 días y controlar con el resultado del urocultivo

Respuesta correcta: b. Iniciar ciprofloxacino 500 mg cada 12 horas por 3 días y controlar con el resultado del urocultivo

Explicación: Tiene una sospecha de infección urinaria baja (ITU baja), ya que no tiene fiebre, como para pensar en una pielonefritis. Ante una clínica y sedimento compatibles, la conducta es iniciar el tratamiento empírico, hasta tener el resultado del cultivo. De elección se usa el ciprofloxacino, o las cefalosporinas de primera generación (ej. cefadroxilo o cefradina), ambos por 3 días. También sirve la nitrofurantoína (7 días). Si el urocultivo de control está negativo, se suspende el tratamiento y se busca otra causa que explique los síntomas. Si está positivo, se termina el tratamiento. Si está positivo para una bacteria resistente, se cambia el tratamiento a un antibiótico, para el que sea sensible. Hay varias opciones en una mujer adulta: 1. Quinolonas orales (ej. Ciprofloxacino); 2. Cefalosporinas orales (ej. Cefadroxilo, cefuroximo o cefixima), 3. Nitrofurantoína (no sirve en la ITU alta, pero sí en la baja), 4. últimamente de moda en algunos países fosfomicina en monodosis (3g), 5. Cotrimoxazol forte. - Algunas recomendaciones prefieren la nitrofurantoína o la fosfomicina como primeras opciones, ya que se concentran especialmente bien en orina, pero se debe recordar que no sirven en las pielonefritis (de elección quinolonas y luego cefalosporinas, en las de tratamiento ambulatorio). - Actualmente, en una mujer joven y sana, con una clínica muy sugerente de cistitis aguda y sedimento compatible, se puede incluso prescindir del urocultivo,.

Fuente: Infectología, cuestionario 9.1, P11

70. Un paciente de 68 años, sin antecedentes de importancia, consulta por un cuadro de malestar general, asociado a fiebre alta, con calofríos y tos abundante, con expectoración, de 5 días de evolución. En el último tiempo ha presentado disnea, la que se ha vuelto de reposo y refiere que se siente muy mal. Al examen físico presenta FC: 113 x´, PA: 120/80, FR: 35x', saturación 89% a FiO2 ambiental. Está disneico y la auscultación pulmonar demuestra crepitaciones en el pulmón derecho. Se solicita una radiografía de tórax, que muestra signos de condensación del lóbulo inferior derecho y el lóbulo medio. ¿Qué antibiótico es más adecuado para el tratamiento de este paciente?

a. Vancomicina
b. Ceftriaxona
c. Claritromicina
d. Amoxicilina
e. Amoxicilina + ácido clavulánico

Respuesta correcta: b. Ceftriaxona

Explicación: SI bien solo tiene 2 puntos del CURB-65 (FR mayor a 30 rpm y edad mayor a 65 años), está desaturando, por lo que requiere soporte con oxígeno (una saturación menor a 90% equivale a una PaO2 menor a 60, es decir, una insuficiencia respiratoria). Por tanto, se debe hospitalizar y tratar con ceftriaxona endovenosa.

Fuente: Infectología, cuestionario 9.1, P17

71. ¿Cuál de los siguientes es un tratamiento adecuado para una pielonefritis aguda, en un paciente ambulatorio?

a. Ciprofloxacino
b. Nitrofurantoína
c. Amoxicilina
d. Clindamicina
e. Cloxacilina

Respuesta correcta: a. Ciprofloxacino

Explicación: La PNA se trata ambulatoriamente con ciprofloxacino (u otra quinolona) y, como alternativa, están las cefalosporinas de primera, segunda o tercera generación oral (primera: cefadroxilo, cefradina, cefalotina; segunda: cefuroximo; tercera: cefixima). - La nitrofurantoína no se concentra bien a nivel renal, por lo que solo sirve en las ITU baja. - Las demás opciones no cubren E. coli.

Fuente: Infectología, cuestionario 9.3, P1

72. Una paciente presenta una piolonefritis aguda de tratamiento ambulatorio, con urocultivo pendiente. El tratamiento de elección será:

a. Cefadroxilo
b. Clindamicina
c. Ampicilina
d. Metronidazol
e. Amoxicilina más ácido clavulánico

Respuesta correcta: a. Cefadroxilo

Explicación: Ciprofloxacino y otras quinolonas, así como las cefalosporinas de primera (cefadrolxilo) y segunda (cefuroximo) o tercera generación (cefixima) son el tratamiento de elección para el tratamiento ambulatorio de la pielonefritis. Se dejan por 7 a 10 días. La nitrofurantoína, solo sirve en el tratamiento de la ITU baja.

Fuente: Infectología, cuestionario 9.5, P13

73. Un paciente, hospitalizado por un AVE secuelado, hace 2 meses, presenta un cuadro de disuria y orinas de mal olor, por lo que se realiza un urocultivo, que muestra desarrollo de una Klebsiella penumoniae BLEE positiva (Betalactamasa de espectro expandido). ¿Qué tratamiento es el más adecuado para el manejo de este paciente?

a. Cefepime
b. Cefoperazona más sulbactam
c. Ceftrixona
d. Ampicilina endovenosa
e. Imipenem

Respuesta correcta: e. Imipenem

Explicación: Las bacterias BLEE se tratan de elección con carbapenémicos (ejemplo: imipenem), ya que son resistentes a todas las cefalosporinas. El ertapenem es más barato, pero no cubre bién Pseudomona (habría sido una respuesta correcta, porque es una Klebsiella y no una Pseudomona).

Fuente: Infectología, cuestionario 9.6, P3

74. Una paciente presenta una pielonefritis aguda grave, por lo que se decide su manejo hospitalizada. El urocultivo muestra desarrollo de una E. coli multisensible. El tratamiento de elección será:

a. Ceftriaxona endovenosa
b. Clindamicina endovenosa
c. Ampicilina endovenosa
d. Metronidazol endovenoso
e. Ciprofloxacino endovenoso

Respuesta correcta: a. Ceftriaxona endovenosa

Explicación: Las PNA graves se tratan con cefalosporinas de tercera generación, como antibiótico de elección (ceftriaxona o cefotaximo). Ciprofloxacino EV es muy caro, aunque sí cubre (el ciprofloxacino oral es barato y se usa en las PNA leves).

Fuente: Infectología, cuestionario 9.6, P13

Infecciones respiratorias (11)

75. Un paciente de 84 años consulta por un cuadro de tos con expectoración pútrida, de 5 días de evolución, asociado a malestar general. Se solicita una radiografía de tórax, que ve una imagen redondeada, de 5 cm de diámetro, con un nivel hidroaéreo, ubicada en el lóbulo inferior derecho. El tratamiento antibiótico más adecuado es:

a. Amoxicilina
b. Clindamicina
c. Ceftriaxona
d. Cloxacilina
e. Metronidazol

Respuesta correcta: b. Clindamicina

Explicación: El tratamiento de elección del absceso pulmonar es antibióticos orales que cubran gram positivos y anaerobios, más drenaje postural. Las opciones más usadas son: - Clindamicina. - Ampicilina-sulbactam o amoxicilina-clavulánico. - Moxifloxacino. - Levofloxacino + metronidazol.

Fuente: Infectología, cuestionario 9.1, P8

76. Un paciente de 50 años consulta por malestar general, fiebre y tos con expectoración mucopurulenta de 4 días de evolución. Refiere que ha presentado hasta 40°C y presenta calofríos solemnes. Al examen físico se constatan crépitos en la base pulmonar derecha, asociada a respiración soplante y aumento de la transmisión de la voz, por lo que se solicita una radiografía de tórax, que muestra condensación de todo el lóbulo inferior derecho. Su frecuencia respiratoria es 22x' y satura 96% a FiO2 ambiental. El agente etiológico más probable es:

a. Mycoplasma pneumoniae
b. Estafilococo dorado
c. Neumococo

d. Anaerobios
e. Pseudomona aureginosa

Respuesta correcta: c. Neumococo

Explicación: Es una neumonía típica clásica (fiebre, tos y expectoración, más signos clínicos y radiológicos de condensación en un lóbulo). La causa más frecuente de NAC clásica es el neumococo. El Mycoplasma es causa de las neumonías atípicas (cuadro que inicia como un resfrío, que dura varios días y va empeorando, con compromiso bilateral, mayor en las bases y patrón alveolointersticial bilateral. El Estafilococo dorado es causa de la neumonía postinfluenza (1 a 2 semanas después de una influenza, con un cuadro grave de neumonía bilateral, cavitada). Los anaerobios son causa de absceso pulmonar. La Pseudomona es causa de neumonía intrahospitalaria, aunque el neumococo sigue siendo la causa más frecuente. * En este caso concreto, no tiene criterios de gravedad y tiene menos de 65 años, por lo que se deberá tratar con amoxicilina. Si fuera alérgico, de elección sería un macrólido.

Fuente: Infectología, cuestionario 9.2, P10

77. Un paciente de 59 años, sin antecedentes de importancia, presenta un cuadro de malestar general, fiebre y tos con expectoración mucopurulenta de dos días de evolución. Al examen físico está en buenas condiciones generales, eupneico y con signos vitales normales, pero se auscultan crepitaciones localizadas en el lóbulo superior izquierdo. Se solicita una radiografía de tórax, que muestra una imagen de condensación en dicho lóbulo. El tratamiento antibiótico más adecuado para este paciente es:

a. Amoxicilina
b. Clindamicina
c. Penicilina G
d. Amoxicilina +ácido clavulánico
e. Moxifloxacino

Respuesta correcta: a. Amoxicilina

Explicación: Tiene una neumonía típica, confirmada con la radiografía. No tiene ningún criterio de gravedad por lo que se debe manejar ambulatoriamente. Además, por ser menor de 65 años y sin patología crónica, de elección se tratará con amoxicilina sola. Si hubiese sido mayor de 65 años o con patología crónica, de elección sería amoxicilina más ácido clavulánico.

Fuente: Infectología, cuestionario 9.3, P2

78. Un paciente de 22 años, es diagnosticado de una neumonía intrahospitalaria, por lo que se solicita cultivo de expectoración, que resulta positivo para pseudomona aureginosa. El estudio de sensibilidad está aún pendiente. ¿Cuál de los siguientes tratamientos le parece más acorde para esto?

a. Amykacina + Ceftazidima
b. Ceftriaxona + metronidazol
c. Cefazolina + clindamicina
d. Penicilina en dosis altas
e. Ampicilina + clindamicina + eritromicina

Respuesta correcta: a. Amykacina + Ceftazidima

Explicación: La pseudomona se cubre con: - Cefalosporinas antipseudomona: ceftazidima, cefoperazona, cefepime y cefiderocol. - Aminoglicósidos: en especial amikacina, tobramicina o kanamicina - Carbapenémicos (menos el ertapenem). - Penicilinas antipseudomona: piperacilina y ticarcilina. -

Quinolonas: Ciprofloxacino, levofloxacino, moxifloxacino. * Lo más usado son los carbapenémicos o bien la mezcla de cefalosporinas antipseudomona más un aminoglicósido antipseudomona.

Fuente: Infectología, cuestionario 9.3, P5

79. Un paciente de 20 años presenta un cuadro de rinorrea y tos de 15 días de evolución, que en último tiempo ha empeorado, agregándose disnea de esfuerzos. Al examen físico presenta buen estado general, con normalidad de las frecuencias cardíaca y respiratoria, la presión arterial y la saturación arterial de oxígeno. Tiene sibilancias y crepitaciones bilaterales y está febril a 38°C. Su radiografía de tórax muestra un patrón alveolointersticial bilateral, con engrosamiento peribronquial. La conducta más adecuada es:

a. Solicitar cultivo de expectoración y hemocultivos
b. Iniciar amoxicilina más ácido clavulánico oral
c. Iniciar ceftriaxona endovenosa
d. Iniciar azitromicina oral
e. Iniciar clindamicina oral

Respuesta correcta: d. Iniciar azitromicina oral

Explicación: Tiene una clínica clásica de neumonía atípica (generalmente causada por mycoplasma): cuadro arrastrado, similar a una infección viral, que evoluciona a una neumonía bilateral, con patrón alveolo-intersticial. Se trata con macrólidos (azitromicina, claritromicina o eritromicina), o bien con quinolonas respiratorias (levofloxacino o moxifloxacino).

Fuente: Infectología, cuestionario 9.3, P7

80. ¿Cuál de las siguientes alternativas es más adecuada para el tratamiento de una amigdalitis de origen bacteriano por S. pyogenes?

a. Penicilina
b. Cloxacilina
c. Cefuroximo
d. Ciprofloxacino
e. Cotrimoxazol

Respuesta correcta: a. Penicilina

Explicación: De elección se usa la penicilina benzatina 1,2 millones de unidades por una vez, o la amoxicilina por 10 días. En alérgicos, se prefieren los macrólidos. La cloxacilina y el cefuroximo sí lo cubren, pero tienen un espectro más amplio del necesario.

Fuente: Infectología, cuestionario 9.3, P19

81. Un paciente de 14 años consulta por tos de 13 días de evolución, asociada disnea que inició hace cerca de 4 días y que ha ido en aumento. Al examen físico se constatan algunas sibilancias y crepitaciones bilaterales, por lo que se solicita una radiografía, que demuestra imágenes de infiltrado alveolointersticial bilateral, con predominancia en las bases. El agente etiológico más probable es:

a. Bordetella pertusis
b. Mycoplasma pneumoniae
c. Micobacterium tuberculosis
d. Streptococcus pneumoniae
e. Aspergillus fumigatus

Respuesta correcta: b. Mycoplasma pneumoniae

Explicación: Tiene una clínica clásica de neumonía atípica (generalmente causada por micoplasma y en segundo lugar Chlamyda penumoniae): cuadro arrastrado, similar a una infección viral, que evoluciona a una neumonía bilateral, con patrón alveolo- intersticial. Se trata con macrólidos (azitromicina, claritromicina o eritromicina), o bien con quinolonas respiratorias (levofloxacino o moxifloxacino).

Fuente: Infectología, cuestionario 9.4, P4

82. Un paciente de 30 años presenta un cuadro de tos, con expectoración, asociado a malestar general, fiebre y posteriormente, dificultad respiratoria. Al examen físico está taquipneico a 35 rpm, febril y taquicárdico a 100x', con saturación arterial de 90% a FiO2 ambiental. El examen pulmonar muestra crepitaciones en la base izquierda. Se solicita una radiografía de tórax, que muestra una imagen de condensación del lóbulo inferior izquierdo. ¿Qué tratamiento antibiótico es el más adecuado para este paciente?

a. Ceftriaxona
b. Amoxicilina más ácido clavulánico
c. Amoxicilina
d. Ceftriaxona más levofloxacino
e. Azitromicina

Respuesta correcta: a. Ceftriaxona

Explicación: Es una neumonía con criterios de hospitalización, por lo que se trata con ceftriaxona. Si bien no cumple con los criterios del CURB 65, sí tiene una desaturación arterial importante, por lo que requiere oxígeno.

Fuente: Infectología, cuestionario 9.5, P1

83. Una paciente de 18 años consulta por malestar general, asociado a fiebre de 38,8°C y odinofagia muy intensa, de un día de evolución. Al examen físico se ve decaída, con frecuencia cardíaca y presión arterial normal. Se palpan adenopatías cervicales bilaterales y se observa una faringe muy eritematosa, con exudado amigdalino bilateral, grisáceo, en pequeñas placas. Se solicita un hemograma, que muestra lecocucitos 13.000 por mm3, con 85% de neutrófilos. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

a. Solicitar Elisa VIH
b. Solicitar IgM VCA
c. Solicitar hemocultivo
d. Iniciar aciclovir
e. Iniciar antibióticos

Respuesta correcta: e. Iniciar antibióticos

Explicación: Es una amigdalitis pultácea que se trata con penicilina o con amoxicilina (macrólidos en alérgicos). No tiene signos catarrales y tiene signos que orientan a bacteria (dolor muy intenso, placas grisáceas). Además, el hemograma muestra leucocitosis de predominio neutrofílico, por lo que orienta a bacteriana. La mononucleosis, en cambio, produce linfocitosis. Recordemos los criterios de Centor: - Fiebre >38ºC. - Adenopatías cervicales. - Exudado amigdalino. - Ausencia de signos catarrales. - Edad entre 3 y 15 años. En este caso, tiene 4 criterios, por lo que está indicado tratar con antibióticos de inmediato.

Fuente: Infectología, cuestionario 9.5, P16

84. Un paciente de 80 años presenta un cuadro de dificultad respiratoria, asociada a fiebre y tos con expectoración mucopurulenta. Al examen físico se ve desorientado, con taquipnea de 40 rpm y cianosis. Su saturación arterial de oxígeno es de 66%, que mejora a 75% al dar oxígeno al 40%. Su frecuencia

cardíaca es 110 x', y su presión arterial es de 90/50 mmHg, además de tener una temperatura de 40°C. Se solicita una radiografía de tórax que demuestra una imagen sugerente de neumonía bilateral, que afecta los lóbulos inferiores de ambos pulmones y el lóbulo medio. Su hemograma muestra leucocitosis de predominio neutrofílico. ¿Qué tratamiento antibiótico es el más adecuado para este paciente?

a. Ceftriaxona
b. Amoxicilina más ácido clavulánico
c. Vancomicina más clindamicina
d. Ceftriaxona más levofloxacino
e. Azitromicina más cloxacilina

Respuesta correcta: d. Ceftriaxona más levofloxacino

Explicación: Requiere de hospitalización en UCI, porque necesita conectarse a Ventilación mecánica, dado que tiene una insuficiencia respiratoria severa. Por regla general, las neumonías en la UCI se tratan con ceftriaxona más azitromicina o levofloxacino y, en algunos contextos epidemiológicos, se usan otros antibióticos, con cobertura de agentes resistentes (Ej. SAMR, Pseudomona aureginosa).

Fuente: Infectología, cuestionario 9.6, P1

85. El tratamiento más adecuado para un paciente con un absceso pulmonar es:

a. Amoxicilina
b. Ceftriaxona
c. Metronidazol
d. Clindamicina
e. Levofloxacino

Respuesta correcta: d. Clindamicina

Explicación: La clindamicina es el tratamiento de elección para el absceso pulmonar (cubre bien anaerobios y también los gram positivos). Se debe además, realizar drenaje postural (si falla, se hace transbronquial). Otras opciones antibióticas que también cubren gram positivos y anaerobios son: 1. ampicilina-sulbactam, 2. amoxicilina-clavulánico, 3. moxifloxacino y 4. lefofloxacino más metronidazol.

Fuente: Infectología, cuestionario 9.6, P4

Endocarditis, bacteriemia e infecciones asociadas a catéter (6)

86. Un paciente de 50 años, con antecedente de amigdalitis a repetición en la infancia, consulta por un cuadro de malestar general, asociado a fiebre. Su examen físico no es capaz de identificar un foco y sólo visualiza algunas petequias en las extremidades inferiores. ¿Qué conducta diagnóstica es más adecuada?

a. Solicitar hemocultivos y serología para Leptospira, Brucella y Bartonella
b. Solicitar ecocardiografía y hemocultivos
c. Solicitar radiografía de tórax y baciloscopías
d. Solicitar cintigrafía ósea
e. Solicitar mielocultivo

Respuesta correcta: b. Solicitar ecocardiografía y hemocultivos

Explicación: La sospecha diagnóstica es una endocarditis infecciosa, la que se estudia con hemocultivos y ecocardiografía. El antecedente de amigdalitis a repetición da a entender que pudo haber tenido una enfermedad reumática. La fiebre sin foco, con pertequias debe hacerla sospechar. En general, se pregunta

también con un soplo. El tratamiento antibiótico suele iniciarse, por vía endovenosa, después de tener el resultado del hemocultivo y se dirige contra el germen identificado: - Staphilococcus aureus: Cloxacilina o cefazolina. - Streptococcus viridans: Penicilina o ampicilina. - Enterococo: ampicilina-sulbactam + gentamicina. * Si resistencia o alergia: Vancomicina cubre los 3 gérmenes resistentes. (se puede agregar rifampicina para potenciar el efecto antiestafilocócico).

Fuente: Infectología, cuestionario 9.1, P1

87. ¿Qué tratamiento indicaría a un paciente con una endocarditis por Enterococo resistente a ampicilina?

a. Penicilina
b. Amoxicilina
c. Ceftriaxona
d. Imipenem
e. Vancomicina

Respuesta correcta: e. Vancomicina

Explicación: La vancomicina es el antibiótico de elección para las bacterias que hacen resistencia, por el mecanismo de mutación de las PBP (Proteínas ligantes de penicilina). Dentro de estas bacterias está el neumococo resistente a penicilina, el S. aureus meticilino resistente y el Enterococo resistente a ampicilina. Además, sirve para cubrir el C. difficile resistente al metronidazol. El tratamiento del eneterococo se puede resumir así: - Enterococo sensible: ampicilina o penicilina. - Enterococo resistente a ampicilina: vancomicina (o teicoplanina). - Enterococo resistente a vancomicina: linezolid, daptomicina o tigeciclina.

Fuente: Infectología, cuestionario 9.1, P5

88. ¿Cuál de los siguientes microorganismos es responsable de la mayoría de las sepsis asociada a catéter intravascular?

a. Estafilococo áureo
b. Streptococcus pyogenes
c. Estafilococo coagulasa negativo
d. Pseudomona aureginosa
e. Acinetobacter baumanii

Respuesta correcta: c. Estafilococo coagulasa negativo

Explicación: La etiología más frecuente de la infección asociada a catéter es el Staphilococcus coagulasa negativa (no aureus). Los clásicos son los S. epidermidis y S. saprophyticum. Al retirar el catéter, se termina la infección, así que retirarlo es lo más importante; aunque, se suele indicar tratamiento antibiótico de todas formas. En segundo lugar, están las infecciones por S. aureus, que pueden ser más graves. Enterococo, cándida, Pseudomona y Klebsiella son los siguientes en frecuencia. En la práctica, el agente se identifica en el hemocultivo o, si el catéter tiene claros signos de infección y se retira, se puede cultivar la punta del mismo.

Fuente: Infectología, cuestionario 9.1, P12

89. Un paciente presenta fiebre y malestar general de 4 días de evolución. En su examen físico presenta un soplo sistólico, por lo que se solicita una ecocardiografía, que muestra vegetaciones mitrales, con una insuficiencia mitral severa. El agente más probable es:

a. Streptococcus pneumoniae
b. Estafilococo coagulasa negativa

c. Estafilococo áureo
d. Streptococcus viridans
e. Streptococcus pyogenes

Respuesta correcta: c. Estafilococo áureo

Explicación: El diagnóstico es una endocarditis infecciosa. Actualmente, por lejos, el agente más frecuente es el S. aureus, que suele ser bastante agresivo y tener un curso rápido. En las de sintomatología subaguda (mayores a 7 días) sin catéteres, lo más probable son los Streptococcus viridans. De todos modos, dado que los hemocultivos suelen estar positivos en la inmensa mayoría de casos, actualmente, se identifica el germen junto al diagnóstico de la endocarditis infecciosa.

Fuente: Infectología, cuestionario 9.3, P9

90. La conducta con mayor efectividad para tratar una infección asociada a catéter intravascular por Staphilococcus coagulasa negativo es:

a. Iniciar penicilina benzatina intramuscular
b. Iniciar penicilina endovenosa
c. Iniciar cloxacilina endovenosa
d. Iniciar vancomicina endovenosa
e. Retirar el catéter

Respuesta correcta: e. Retirar el catéter

Explicación: Dado que el foco infeccioso se limita al catéter, retirarlo suele ser el único tratamiento requerido. Se recomienda complementar con antibióticos, pero lo más importante, por lejos, es retirar el catéter.

Fuente: Infectología, cuestionario 9.3, P10

91. Un paciente, hospitalizado por un AVE secuelado, hace 2 meses, presenta un cuadro de fiebre y malestar general, por lo que se realiza un hemocultivo, que muestra desarrollo de un Staphilococcus aureus meticilino resistente (SAMR). ¿Qué tratamiento es el más adecuado para el manejo de este paciente?

a. Cefepime
b. Vancomicina
c. Cloxacilina
d. Gentamicina
e. Imipenem

Respuesta correcta: b. Vancomicina

Explicación: El SAMR tiene resistencia por mutación de PBP (Penicilin binding protein) por lo que ningún betalactámico lo cubre, ni siquiera los carbapenémicos, así que el tratamiento de elección es la vancomicina, un glicopéptido. Sirven también el linezolid y la daptomicina. Además, algunos SAMR pueden ser tratados por otros antibióticos, de acuerdo a su antibiograma.

Fuente: Infectología, cuestionario 9.5, P3

Infecciones osteoarticulares (3)

92. La mayoría de las osteomielitis en el adulto mayor son producidos por:

a. Pseudomona aureginosa

b. Bacteroides fragilis
c. Streptococcus pyogenes
d. Staphilococcus aureus
e. Streptococcus viridans

Respuesta correcta: d. Staphilococcus aureus

Explicación: A todas las edades, el S. aureus es la causa más frecuente de osteomielitis (>90% de los casos).

Fuente: Infectología, cuestionario 9.3, P20

93. Un paciente de 80 años consulta por dolor intenso de la rodilla izquierda, la que se aprecia aumentada de volumen y eritematosa, con signos de derrame articular y aumento de la temperatura local. Se realiza punción articular, dando salida a un líquido turbio, fluido, con más de 100.000 GB por mm3 y presencia de abundantes cocáceas gram positivas. La conducta más adecuada es:

a. Iniciar clindamicina y realizar drenaje articular quirúrgico
b. Iniciar vancomicina y realizar drenaje articular quirúrgico
c. Iniciar penicilina y realizar drenaje articular quirúrgico
d. Iniciar ceftriaxona y realizar drenaje articular quirúrgico
e. Iniciar cefepime y realizar drenaje articular quirúrgico

Respuesta correcta: b. Iniciar vancomicina y realizar drenaje articular quirúrgico

Explicación: Tiene una artritis séptica, la que se trata con antibióticos más drenaje quirúrgico, idealmente por artroscopia. En este caso es por S. aureus (cocáceas Gram positivas), por lo que se debe indicar vancomicina endovenosa (sería aceptable iniciar cloxacilina o cefazolina también, en especial, si es que está en excelente condiciones; pero, el aumento de SAMR ha hecho que actualmente se recomiende la vancomicina en los casos de infecciones graves, causadas por Staphilococcus, incluyendo la artritis séptica, al menos hasta contar con el antibiograma). - La clindamicina sería una respuesta correcta si fuera alérgico a la penicilina. - La ceftriaxona sería correcta si fuera por gonococo (cocáceas Gram negativa). - El cefepime sería correcto si hubiese bacilos Gram negativos (Pseudomona).

Fuente: Infectología, cuestionario 9.4, P13

94. Un paciente de 75 años presenta una monoartritis aguda de rodilla izquierda, que es puncionada, mostrando un líquido turbio, con presencia de cristales de pirofosfato de calcio y abundantes cocáceas gram positivas. La conducta más adecuada es:

a. Iniciar vancomicina endovenosa y realizar aseo quirúrgico de la articulación
b. Iniciar penicilina endovenosa y realizar aseo quirúrgico de la articulación
c. Iniciar ceftriaxona endovenosa y realizar aseo quirúrgico de la articulación
d. Iniciar cloxacilina endovenosa
e. Iniciar ceftriaxona endovenosa

Respuesta correcta: a. Iniciar vancomicina endovenosa y realizar aseo quirúrgico de la articulación

Explicación: Es una artritis séptica que requiere aseo quirúrgico, idealmente por artroscopía más antibióticos endovenosos. En este caso es por S. aureus (por ser cocácea G+). - Las cepas sensibles (SAMS) se tratan con cloxacilina o cefazolina endovenosa. - Las cepas resistentes (SAMR) se tratan con vancomicina - Actualmente, dado el aumento del SAMR, se recomienda cubrirlo, mientras no se cuente con el antibiograma. (*) La ceftriaxona sería correcta en una infección por gonococo (cocácea Gram negativa intracelular).

Fuente: Infectología, cuestionario 9.6, P14

Diarrea infecciosa y fiebre tifoidea (9)

95. Un paciente de 28 años, presenta un cuadro de diarrea disentérica y fiebre hasta 38,7°C, de dos días de evolución. Refiere haber comido verduras sin lavar. El tratamiento antibiótico más adecuado es:

a. Metronidazol
b. Amoxicilina
c. Ciprofloxacino
d. Clindamicina
e. Claritromicina

Respuesta correcta: c. Ciprofloxacino

Explicación: Por regla general, las diarreas agudas no deben recibir antibióticos, pero sí se indica en la disentería y cuando hay fiebre mayor a 48 horas o aspecto séptico. De elección se indica ciprofloxacino, ya que cubre bien las enterobacterias, como la Shigella, Escherichia coli, Yersinia, Campilobacter, etc. En este caso, por tener una disentería aguda, la Shigella es el agente más probable, seguido de algunas cepas de E. coli (enteroinvasiva y enterohemorrágica, que es la causante del SHU).

Fuente: Infectología, cuestionario 9.1, P6

96. El tratamiento antibiótico de elección de la infección por C. difficile no complicada es:

a. Ciprofloxacino
b. Azitromicina
c. Vancomicina
d. Clindamicina
e. Metronidazol

Respuesta correcta: e. Metronidazol

Explicación: Diarrea por Clostridium difficile (actualmente llamado Clostridioides difficile) – metronidazol o vancomicina. - Si es leve o moderada, se recomienda comenzar con metronidazol oral por 14 días. - Si es severa (falla renal, hipoalbuminemia severa, blancos >15.000 por mm3), se prefiere iniciar directamente con vancomicina oral por 10 días (por ser más afectiva y tener menos resistencia; de hecho, en países en que hay mucha resistencia, se recomienda la vancomicina o la fidaxomicina como tratamiento de primera línea en los casos leves también, pero este no es el caso de Chile, por ahora). - Si, además de ser severa, está complicada (perforación, megacolon, shock, íleo paralítico), se prefiere el uso combinado de metronidazol endovenoso más vancomicina oral (no llega bien al intestino cuando se da endovenosa; en el caso de íleo, que contraindique la vía oral, se puede dar vía rectal). - En las recurrencias, 1. se repite el antibiótico dado inicialmente, 2. si recurre, se recomienda vancomicina en dosis crecientes, 3. Si recurre por tercera vez, se recomienda vancomicina por periodos prolongados, seguido de rifaximina y se empieza a evaluar el trasplante fecal. * Sobre el diagnóstico, actualmente se prefiere la PCR para C. difficile sobre la detección de toxinas en deposiciones.

Fuente: Infectología, cuestionario 9.2, P20

97. Un paciente de 40 años recibe amoxicilina + ácido clavulánico por 10 días, debido a una sinusitis bacteriana aguda, evolucionando favorablemente. Sin embargo, inicia diarrea acuosa abundante y dolor abdominal. Se solicita PCR para C. difficile en deposiciones, la que resulta positiva. La conducta más adecuada es:

a. Iniciar moxifloxacino
b. Iniciar clindamicina
c. Iniciar vancomicina + clindamicina
d. Iniciar vancomicina + gentamicina
e. Iniciar metronidazol

Respuesta correcta: e. Iniciar metronidazol

Explicación: El tratamiento de elección de la diarrea por Clostridioides difficile es el metronidazol. Solo si falla, se repite y si vuelve a fallar, se indica la vancomicina oral. ¿Qué antibiótico dejar de primera línea? - Casos leves y moderados: MTZ. - Casos graves: Vancomicina oral. - Casos muy graves complicados (perforación, íleo): MTZ + vancomicina.

Fuente: Infectología, cuestionario 9.3, P14

98. Un paciente de 45 años presenta un cuadro de 10 días de malestar general, asociado a fiebre alta y diarrea. Al examen físico presenta además un exantema rosado, por lo que se solicitan exámenes generales, destacando un hemograma, que sugiere fiebre tifoidea (leucopenia + desviación izquierda + aeosinofilia). El examen de elección para confirmar la sospecha diagnóstica es:

a. Mielocultivo
b. Hemocultivo
c. IgG para Salmonella typhi
d. IgM para Salmonella typhi
e. Inmunofluorescencia directa para Salmonella typhi en deposiciones

Respuesta correcta: b. Hemocultivo

Explicación: Los hemocultivos son el examen de elección para el diagnóstico de la fiebre tifoidea, ya que tienen sensibilidades entre 50% y 80% (mejor en las primeras dos semanas de síntomas). También se suele pedir coprocultivo, aunque su sensibilidad es menor. El mielocultivo es el examen más sensible, pero solo se pide cuando la sospecha es muy alta y el hemocultivo está negativo, ya que es más caro y doloroso (requiere punción ósea). La serología tiene baja sensibilidad. Actualmente, la PCR para Salmonella Typhi estaría cobrando relavencia, aunque su sensibilidad ha sido muy variable, según distintos estudios. * El tratamiento suele ser el ciprofloxacino o ceftriaxona. En casos de muy alta sospecha, se trata, incluso con exámenes negativos.

Fuente: Infectología, cuestionario 9.3, P16

99. El tratamiento más adecuado para la disentería por Entamoeba hystolytica es:

a. Sintomático
b. Albendazol
c. Cotrimoxazol
d. Metronidazol
e. Praziquantel

Respuesta correcta: d. Metronidazol

Explicación: El metronidazol es el tratamiento de elección para la amebiasis (Entamoeba hystolitica). También sirve el tinidazol. - Recordar que la Entamoeba coli es normal y no debe tratarse. - El albendazol se usa para los gusanos cilíndricos (ej. áscaris, triquina). - El praziquantel se usa para los gusanos planos (ej. teniasis).

Fuente: Infectología, cuestionario 9.4, P12

100. El tratamiento más adecuado para un paciente con disentería amebiana es:

a. Cotrimoxazol
b. Mebendazol
c. Metronidazol
d. Clindamicina
e. Aztreonam

Respuesta correcta: c. Metronidazol

Explicación: La Entamoeba histolytica se trata con metronidazol o tinidazol. La Entamoeba coli no se trata, ya que es un comensal.

Fuente: Infectología, cuestionario 9.5, P4

101. Un paciente de 30 años presenta un cuadro de diarrea aguda, de 2 días de evolución, acuosa, asociada a dolor abdominal tipo cólico. Además de hidratar, ¿Qué antibiótico debe administrarse?

a. Ninguno
b. Metronidazol oral
c. Ciprofloxacino oral
d. Amoxicilina oral
e. Cefradina oral

Respuesta correcta: a. Ninguno

Explicación: Las diarreas agudas por regla general no requieren antibióticos, porque son virales. Las indicaciones de antibióticos son disentería, aspecto séptico, fiebre mayor a 2 días y algún contexto epidemiológico que oriente a bacterias que requieran antibióticos (diarrea del viajero, intoxicación alimentaria en brote por Salmonella, brote de cólera, etcétera).

Fuente: Infectología, cuestionario 9.5, P17

102. Un paciente de 30 años presenta un cuadro de disentería aguda, de 2 días de evolución, asociado a fiebre y malestar general. Además de hidratar se debe:

a. Iniciar cloxacilina oral
b. Iniciar metronidazol oral
c. Iniciar ciprofloxacino oral
d. Iniciar amoxicilina oral
e. Observar evolución

Respuesta correcta: c. Iniciar ciprofloxacino oral

Explicación: La disentería se trata de elección con ciprofloxacino, porque cubre Shigella y E. Coli (ECEI: E. coli enteroinvasora)

Fuente: Infectología, cuestionario 9.6, P17

103. El tratamiento de elección de la fiebre tifoidea es, actualmente:

a. Ceftriaxona
b. Ciprofloxacino
c. Metronidazol
d. Rifampicina
e. Tetraciclina

Respuesta correcta: b. Ciprofloxacino

Explicación: El ciprofloxacino además logra eliminar la portación biliar. La ceftriaxona sí lo cubre y se puede dejar en un caso con sepsis y necesidad de fármacos endovenosos.

Fuente: Infectología, cuestionario 9.6, P19

Parasitosis (7)

104. Un paciente de 45 años, con antecedente de viaje a Brasil hace 3 semanas, consulta por fiebre y mialgias intensas, que iniciaron hace 7 días y que no han mejorado con el uso de paracetamol e ibuprofeno. Refiere debilidad y dolor que dificulta sus actividades. Al examen físico se constata dolor a la palpación muscular y discreto edema periocular. Se solicitan exámenes generales, entre los que destaca hemograma con leucocitosis de 15.000 y 50% de eosinófilos. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

a. Triquinosis
b. Dengue
c. Malaria
d. Influenza
e. Mononucleosis

Respuesta correcta: a. Triquinosis

Explicación: Tiene una triquinosis clásica. Como la fiebre empezó después de 7 días del viaje, es improbable un dengue o malaria, además que solo la triquinosis produce eosinofilia. La serología es la que da el diagnóstico, pero demora cerca de un mes en positivizar, por lo que la biopsia muscular suele ser de utilidad en la fase aguda. Además, la mayoría de las veces el tratamiento es solo sintomático, con analgésicos, siendo de utilidad los corticoides y, discutiblemente, los antiparasitarios (albendazol o mebendazol) en los cuadros más severos.

Fuente: Endocrinología y diabetes, cuestionario 7.8, P9

105. Un paciente de 20 años consulta porque en sus deposiciones apareció un gusano de cerca de 12 cm de largo. Se solicita un parasitológico de deposiciones, que visualiza huevos de Ascaris lumbricoides. La conducta más adecuada es:

a. Observar evolución
b. Iniciar metronidazol
c. Iniciar praziquantel
d. Iniciar albendazol
e. Iniciar cotrimoxazol

Respuesta correcta: d. Iniciar albendazol

Explicación: Los áscaris se tratan con albendazol o mebendazol en una dosis. Como opción está el pamoato de pirantel, en especial en embarazadas.

Fuente: Infectología, cuestionario 9.2, P2

106. Un paciente de 66 años, oriundo de Aysén, consulta por tos intensa, asociada a salida de líquido transparente, con presencia de membranas, como hollejo de uva. Se solicita una radiografía de tórax, visualizándose una imagen compatible con un quiste hidatídico. ¿Cómo se contrajo esta enfermedad?

a. Por ingerir alimentos contaminados con deposiciones de perro
b. Por ingerir alimentos contaminados con deposiciones humanas
c. Por ingerir plantas acuáticas contaminadas
d. Por ingerir carnes contaminadas
e. Por la picadura de un insecto

Respuesta correcta: a. Por ingerir alimentos contaminados con deposiciones de perro

Explicación: La hidatidosis se adquiere consumiendo huevos de Echinococcus granulosus, que están en las deposiciones de perro, zorros y otros cánidos, que son el huésped final. El húesped intermedio suelen ser ovejas, cabras o cerdos y, en el caso del humano, es un huésped intermedio incidental. Se dice que es la "enfermedad del porfiado", ya que los perros se infectan por ser alimentados con vísceras de ovejas u otros huéspedes intermedios, en lugar de alimentos cocidos o libres de parásitos. - La fasciolasis o distomatosis se produce por consumir plantas acuáticas (berros). - La triquiniasis y la teniasis se producen por consumir carnes contaminadas (carne de cerdo en triquina y Taenia solium; carne de vaca en Taenia saginata). - La enfermedad de Chagas se produce por picadura de insecto (vinchuca o chinche picuda).

Fuente: Infectología, cuestionario 9.2, P11

107. Un paciente de 56 años, oriundo de Temuco, consulta por un cuadro de 7 días de evolución de malestar general y dolor abdominal. Al examen está ictérico, con fiebre hasta 37,8°C y se palpa hepatomegalia sensible, de 3 cm bajo el reborde costal. Se solicita un hemograma que demuetra lecucocitosis de 12.000, con 30% de eosinófilos. El diagnóstico más probable es:

a. Distomatosis
b. Hidatidosis
c. Absceso hepático piógeno
d. Absceso hepático amebiano
e. Hepatitis vitral

Respuesta correcta: a. Distomatosis

Explicación: Temuco es una ciudad del sur de Chile. La triada de ictericia, fiebre y eosinofilia es característica de la distomatosis o fasciolasis hepática, que se produce por comer plantas acuáticas (ej. berros), contaminadas con Fasciola hepática. La hidatidosis también es común en el sur de Chile, pero generalmente no tiene mayor clínica y rara vez tiene eosinofilia. Los abscesos y la hepatitis viral tampoco tienen eosinofilia.

Fuente: Infectología, cuestionario 9.4, P5

108. La asociación de fiebre, mialgias y eosinofilia es característica de:

a. La teniasis
b. La larva migrante visceral
c. La triquinosis
d. La distomatosis
e. El ciclo de Löffler

Respuesta correcta: c. La triquinosis

Explicación: Teniasis: molestias abdominales inespecíficas. - Larva migrante visceral: eosinofilia, síntomas inespecíficos según la localización (ej. ceguera, si ocular). - Triquinosis: mialgias, fiebre y eosinofilia. - Distomatosis: ictericia, fiebre y eosinofila. - Síndrome de Löffler: tos, asma, fiebre y eosinofila (por Ascaris lumbricoides en la fase inicial pulmonar).

Fuente: Infectología, cuestionario 9.4, P10

109. Un paciente presenta malestar abdominal y baja de peso. Se solicita un examen parasitológico de deposiciones, que muestra huevos y proglótidas de Taenia sollium. ¿Cómo se infestó?

a. Comiendo alimentos contaminados con heces de cerdo
b. Comiendo alimentos contaminados con heces humanas
c. Comiendo carne de cerdo con cisticercos
d. Comiendo plantas acuáticas infestadas, como los berros
e. Mediante la picadura de un insecto

Respuesta correcta: c. Comiendo carne de cerdo con cisticercos

Explicación: La teniasis se contagia con la ingesta de carne con cisticercos (la T. solium es carne de cerdo, la T. Saginata es con carne de vaca y el Diphyllobotrium Latum es con carne de pescado). La cisticercosis, en cambio, se contagia consumiendo alimentos contaminados con deposiciones humanas (con huevos de T. solium). La distomatosis o fasciolasis se contagia comiendo plantas acuáticas (berros, por ejemplo). La enfermedad de Chagas se contagia por picadura de insectos, al igual que la filariasis y la oncocercosis.

Fuente: Infectología, cuestionario 9.6, P5

110. Un niño presenta dolor abdominal intermitente. Se realiza exámenes que muestran anemia ferropénica y eosinofilia. La madre refiere además que ha visto gusanos en sus deposiciones y el parasitológico de deposiciones confirma la presencia de Ascaris lumbricoides. El tratamiento más adecuado es:

a. Metronidazol
b. Praziquantel
c. Nifurtimox
d. Albendazol
e. Sulfas

Respuesta correcta: d. Albendazol

Explicación: La ascariasis se trata con albendazol o mebendazol.

Fuente: Infectología, cuestionario 9.6, P10

Enfermedades exantemáticas y virosis (10)

111. Una paciente de 30 años, cursando un embarazo de 12 semanas acude a la consulta, ya que su hijo de 6 años está con varicela, en buen estado, siendo tratado con paracetamol. Ella no recuerda haber tenido varicela de niña y teme por su bebé. No ha recibido vacunas contra la varicela. Se solicita serología a la paciente, mostrando IgM varicela negativa e IgG varicela positiva. ¿Cuál es la conducta más adecuada con ella?

a. Iniciar aciclovir por vía oral
b. Tranquilizar y explicar que no tiene riesgo

c. Iniciar aciclovir endovenoso
d. Vacunar contra la varicela
e. Administrar inmunoglobulina hiperinmune contra la varicela

Respuesta correcta: b. Tranquilizar y explicar que no tiene riesgo

Explicación: Por tener IgG positiva para varicela, se asume que sí se contagió antes y no tiene riesgo. Si la IgG hubiese estado negativa, lo más adecuado sería indicar profilaxis, con la inmunoglobulina hiperinmune. El aciclovir se usa solo si es que tiene síntomas, por vía oral y en los casos graves (ej. neumonía varicelatosa), se deja por vía endovenosa.

Fuente: Endocrinología y diabetes, cuestionario 7.8, P7

112. Un paciente de 20 años consulta por un cuadro de malestar general y fiebre alta, de una semana de evolución, asociada a odinofagia. Al examen físico presenta faringe eritematosa, con amígdalas aumentadas de tamaño, con exudado blanquecino en su superficie. Además, se palpan algunas adenopatías cervicales. Se indica amoxicilina oral, sin embargo, el paciente consulta al día siguiente por aparición de un exantema eritematoso generalizado. El diagnóstico de sospecha es:

a. Escarlatina
b. Leptospirosis
c. Síndrome retroviral agudo
d. Mononucleosis infecciosa
e. Enfermedad por arañazo de gato

Respuesta correcta: d. Mononucleosis infecciosa

Explicación: Es una presentación clásica de la mononucleosis: fiebre, odinofagia y adenopatías, más el rash que suele aparecer luego de iniciar aminopenicilinas (amoxicilina y ampicilina). El exudado blanco adherente y grande es característico de mononucleosis. La escarlatina, en cambio, tiene un exantema papular, áspero al tacto (piel de gallina), con la clínica de una amigdalitis estreptocócica (dolor intenso, fiebre y adenopatías, con exudado grisáceo en los surcos).

Fuente: Infectología, cuestionario 9.2, P5

113. Un paciente de 10 años consulta por odinofagia, fiebre y aparición de lesiones en la cavidad oral. Al examen físico se aprecian múltiples úlceras orales, ubicadas en la lengua, las encías y el paladar, asociadas a adenopatías cervicales bilaterales. El agente etiológico más probable es:

a. Virus Coxsackie
b. Virus herpes simplex
c. Adenovirus
d. Virus varicela zoster
e. Streptococcus pyogenes

Respuesta correcta: b. Virus herpes simplex

Explicación: Parece una gingivoestomatitis herpética: vesículas y úlceras en toda la boca (encías, labios, lengua, paladar) y fiebre. El virus Coxsackie produce herpangina (lactantes con fiebre y vesículas o úlceras, pero solo en el paladar blando). El adenovirus produce faringitis (que puede ser exudativa), habitualmente con conjuntivitis.

Fuente: Infectología, cuestionario 9.2, P17

114. Un niño presenta un cuadro de fiebre alta, calofríos, tos y conjuntivitis bilateral, a lo que se agrega un exantema rojo intenso generalizado, que inició en la cara y luego se extendió al resto del cuerpo. El cuadro descrito es característico de:

a. Sarampión
b. Rubéola
c. Eritema infeccioso
d. Exantema súbito
e. Escarlatina

Respuesta correcta: a. Sarampión

Explicación: Es un sarampión clásico: exantema rojo, con fiebre y malestar, precedido por tos y conjuntivitis. Suele iniciar en la cabeza y luego se extiende en sentido cefalocaudal. - La rubéola suele ser un exantema rosado, tenue, con artralgias y con adenopatías retroauriculares y cervicales posteriores. - El eritema infeccioso suele comenzar con eritema malar ("cachetada") y se sigue luego de un exantema reticular. - El exantema súbito suele ser en lactantes (< 2 años) con fiebre alta, que cede y luego aparece un exantema generalizado y ralo. - La escarlatina suele estar asociada a una amigdalitis pultácea (u otra infección estreptocócica) y tiene un exantema papular, áspero (en piel de gallina), con líneas de Pastia, que respeta el triángulo de Filatov. * (Nota: en este caso, hasta antes del exantema, podría haber sido un adenovirus).

Fuente: Infectología, cuestionario 9.2, P19

115. Un niño de 6 años presenta un cuadro de malestar general y fiebre hasta 38,4°C, que luego es seguido por un exantema que inició en las mejillas y luego se hizo generalizado, con lesiones maculares eritematosas, en disposición reticular. El agente más probable es:

a. Parvovirus B19
b. Virus rubéola
c. Virus sarampión
d. Virus herpes 6
e. Virus herpes 8

Respuesta correcta: a. Parvovirus B19

Explicación: Es un eritema infeccioso clásico (también se llama quinta enfermedad): fiebre y exantema en mejillas (signo de la cachetada), que se sigue de un exantema reticular o "en encaje" en el tronco y extremidades. Es causado por el parvoirus B19 (PVB19). El virus herpes 6 produce el exantema súbito (lactante con fiebre muy alta, que cede y da paso a un exantema maculopapular generalizado y ralo). El virus herpes 8 es la causa del sarcoma de Kaposi, en el paciente VIH.

Fuente: Infectología, cuestionario 9.4, P2

116. Un niño de 6 años consulta por un cuadro de malestar general, asociado a fiebre alta, de una semana de evolución. Refiere dolor al tragar y mialgias. Al examen físico se aprecia hepatoesplenomegalia, faringe eritematosa, con exudado blanco bilateral y múltiples adenopatías cervicales dolorosas. El diagnóstico más probable es:

a. Amigdalitis pultácea
b. Difteria
c. Hepatitis aguda por virus A
d. Mononucleosis

e. Herpangina

Respuesta correcta: d. Mononucleosis

Explicación: Tiene un síndrome mononucléosico: fiebre, odinofagia y adenopatías. El exudado, es uno de los criterios de Centor de la amigdalitis estreptocócica (también tiene fiebre, odifagia y adenopatías), sin embargo, también es muy frecuente que haya exudado en la mononucleosis (en la que es blanco y grande; en cambio en la amigdalitis bacteriana, suele ser pequeño y grisáceo, localizado en los surcos). De todos modos, la presencia de hepatoesplenomegalia orienta fuertemente a mononucleosis. La presencia de rash puede corresponder tanto a mononucleosis (rash morbiliforme aparece en 30% de los casos, elevándose a 90% si es que recibe aminopenicilinas como la amoxicilina o ampicilina) como a la amigdalitis bacteriana, que puede presentarse como una escarlatina (rash papular áspero y seco, mayor en los pliegues, con lengua saburral o en fresa roja o blanca y líneas de Pastia).

Fuente: Infectología, cuestionario 9.4, P9

117. Una paciente de 35 años, embarazada presenta un cuadro de fiebre, mialgias y aparición de un exantema vesicular generalizado, muy pruriginoso. Dos días después inicia cuadro de tos, con disnea, constatándose taquipnea importante y desaturación arterial de oxígeno, por lo que se solicita una radiografía de tórax, que muestra un infiltrado intersticial bilateral, difuso. El diagnóstico más probable es:

a. Listeriosis
b. Leptospirosis
c. Neumonía varicelatosa
d. Neumonía estafilocócica
e. Tuberculosis miliar

Respuesta correcta: c. Neumonía varicelatosa

Explicación: Comenzó como una varicela clásica: exantema pruriginoso vesiculopustular (aunque luego se vuelve polimorfo), precedido por fiebre, mialgias y compromiso del evolucionar a una neumonía viral grave (neumonía varicelatosa o neumonitis varicelatosa), la que se debe tratar con soporte y aciclovir por vía endovenosa.

Fuente: Infectología, cuestionario 9.4, P20

118. Un paciente de 6 años presenta un cuadro de malestar general, odinofagia y fiebre de 38°C, seguido de aparición de vesículas en las manos y pies, que compromete palmas y plantas. Además, se aprecian algunas úlceras en el paladar blando. ¿Qué fármaco es el más adecuado para el manejo de este paciente?

a. Valaciclovir
b. Paracetamol
c. Prednisona
d. Aspirina
e. Amoxicilina

Respuesta correcta: b. Paracetamol

Explicación: Es un síndrome pie mano boca clásico, que se trata de manera sintomática y de elección con paracetamol. Si bien la aspirina sirve para el tratamiento sintomático, no es de elección porque tiene más efectos adversos (falla renal, úlcera gastroduodenal, síndrome de Reye).

Fuente: Infectología, cuestionario 9.5, P20

119. Una paciente de 18 años consulta por malestar general, asociado a fiebre de 38,8°C y odinofagia. Al examen físico se ve decaída, con frecuencia cardíaca y presión arterial normal. Se palpan adenopatías cervicales bilaterales y se observa una faringe eritematosa, con exudado amigdalino bilateral, blanquecino, que recubre gran parte de la superficie amigdalina. Además, se palpa cierto grado de esplenomegalia. ¿Qué examen es más adecuado para confirmar el diagnóstico?

a. Elisa VIH
b. IgM VCA
c. Hemocultivo
d. IgM para Bartonella
e. Cultivo faríngeo

Respuesta correcta: b. IgM VCA

Explicación: La clínica es de mononucleosis, que se confirma con IgM VCA (viral capsid antigen), que también se llama IgM VEB (virus Ebstein Baar).

Fuente: Infectología, cuestionario 9.6, P16

120. Un paciente de 20 años presenta un cuadro de malestar general y fiebre de 38°C, seguido de aparición de un exantema generalizado, que inició en la cara y luego se extendió al tronco y finalmente las extremidades. El exantema es muy pruriginoso y es de tipo vesículo-pustular, que evoluciona luego a costras. La conducta más adecuada es:

a. Iniciar valaciclovir oral, asociado a pracetamol y un antihistamínico H1
b. Iniciar ibuprofeno y observar evolución
c. Iniciar corticoides orales y un antihistamínico H1
d. Iniciar aspirina y un antihistamínico H1
e. Iniciar antibióticos orales, con cobertura para gram positivos

Respuesta correcta: a. Iniciar valaciclovir oral, asociado a pracetamol y un antihistamínico H1

Explicación: Es una varicela clínica (diagnóstico es clínico). Se trata con aciclovir/valaciclovir en mayores de 13 años, más el tratamiento sintomático con paracetamol y antiH1.

Fuente: Infectología, cuestionario 9.6, P20

Zoonosis y enfermedades transmitidas por vectores (6)

121. Un paciente de 40 años, consulta por un cuadro de fiebre alta, mialgias intensas, cefalea retroocular y malestar general, que inició hace 48 horas. No presenta signos respiratorios y su examen cardiopulmonar es normal. Como dato importante, refiere haber viajado a Brasil recientemente. Se solicita un hemograma que muestra Hcto: 54%, plaquetas: 50.000 por mm3, blancos: 4.000 por mm3, con 90% de linfocitos. El diagnóstico más probable es:

a. Malaria
b. Esquistosomiasis
c. Dengue
d. Fiebre amarilla
e. Fiebre tifoidea

Respuesta correcta: c. Dengue

Explicación: Es un dengue clásico: mialgias intensas más fiebre alta (fiebre quebranta huesos) luego de viaje a zona expuesta. Además tiene el hemograma clásico: sin anemia (puede tener hemoconcentración), con trombopenia y leucopenia. La malaria, en cambio, tiene anemia. La fiebre amarilla tiene un cuadro distinto, con ictericia o una especie de sepsis viral, con compromiso gastrointestinal y hemorragias ("vómito negro"). La fiebre tifoidea tiene diarrea y su hemograma se caracteriza por leucopenia con desviación izquierda.

Fuente: Infectología, cuestionario 9.2, P16

122. Un paciente acude a la consulta por un cuadro de malestar general importante, asociado a mialgias y fiebre, que inició 10 días después de haber regresado de un viaje a Brasil. Al examen físico se aprecia pálido, con esplenomegalia y en sus exámenes destaca un hemograma con Hcto: 25%, blancos: 12.000 por mm3, plaquetas: 60.000 por mm3. Además, presenta elevación discreta de las transaminasas. El diagnóstico más probable es:

a. Malaria
b. Dengue
c. Fiebre amarilla
d. Fiebre tifoidea
e. Leptospirosis

Respuesta correcta: a. Malaria

Explicación: Tanto la malaria, como el dengue pueden producir fiebre, mialgias, hepatitis, etc. Sin embargo, la presencia de anemia sugiere fuertemente una malaria (puede venir además con trombopenia y con leucocitosis o leucopenia). En cambio el dengue generalmente no tiene anemia, sino hemoconcentración, con leucocitosis y plaquetopenia. La fiebre amarilla tiene un cuadro distinto, con ictericia o una especie de sepsis viral, con compromiso gastrointestinal y hemorragias ("vómito negro"). La fiebre tifoidea tiene diarrea y su hemograma se caracteriza por leucopenia con desviación izquierda. La leptospirosis suele tener fiebre, malestar general, meningitis aséptica, conjuntivitis hemorrágica, más hepatitis e insuficiencia renal.

Fuente: Infectología, cuestionario 9.4, P18

123. ¿Cuál es el diagnóstico más probable ante un paciente que presenta simultáneamente una insuficiencia cardíaca por miocardiopatía dilatada y un megacolon, con pseudosbtrucción intestinal?

a. Triquinosis
b. Endocarditibs bacteriana subaguda
c. Síndrome de inmunodeficiencia adquirida
d. Enfermedad de Chagas
e. Infección por enterovirus

Respuesta correcta: d. Enfermedad de Chagas

Explicación: Sería una enfermedad de Chagas en la fase dilatada. Recordar que en la fase inicial es muy inespecífica, excepto el signo de Romaña (edema de un párpado), por lo que lo característico es la fase dilatada, que cursa con megacolon, megaesófago y miocardiopatía dilatada.

Fuente: Infectología, cuestionario 9.5, P5

124. Un paciente de 64 años llega de un viaje a Brasil. Al día siguiente inicia un cuadro de malestar general, asociado a fiebre alta e intensas mialgias generalizadas. Al examen físico destacan múltiples

petequias en la zona del brazo, donde se le tomó la presión (signo del torniquete). El diagnóstico más probable es:

a. Fiebre amarilla
b. Influenza
c. Malaria
d. Dengue
e. Enfermedad de Chagas

Respuesta correcta: d. Dengue

Explicación: Es un dengue clásico (fiebre alta y mialgias intensas, más signo del torniquete). Como cosa adicional, el dengue puede presentar un exantema eritematoso en "mar rojo, con islas blancas". Su hemograma no tiene anemia, lo que lo diferencia de la malaria. El diagnóstico de certeza se hace con serología (IgM positiva). El tratamiento es sintomático. En los casos graves (dengue hemorrágico o shock), requiere soporte en el hospital. El dengue rara vez se complica en la primera infección. Los casos graves suelen producirse en personas que ya tuvieron dengue, pero por otra variante del virus (hay 4 variantes principales: tipos 1, 2, 3 y 4).

Fuente: Infectología, cuestionario 9.5, P18

125. El tratamiento de elección de la enfermedad por arañazo de gato es:

a. Ceftriaxona
b. Ciprofloxacino
c. Metronidazol
d. Azitromicina
e. Tetraciclina

Respuesta correcta: d. Azitromicina

Explicación: En general los macrólidos son el tratamiento de elección para la Bartonella Henselae. Generalmente se prefiere la azitromicina por 5 días (menor duración que los demás macrólidos y solo una dosis diaria). Como alternativas están la rifampicina, cotrimoxazol (sulfamteoxazol más trimetoprim), doxiciclina y el ciprofloxacino.

Fuente: Infectología, cuestionario 9.5, P19

126. Un paciente de 34 años llega de un viaje a las playas de Ecuador (Montañita). Al día siguiente inicia un cuadro de malestar general, asociado a fiebre alta e intensas mialgias generalizadas. Al examen físico además se aprecian algunas petequias en las extremidades y se solicita un hemograma que muestra Hcto: 48%, plaquetas: 90.000 y blancos 11.000. El diagnóstico más probable es:

a. Fiebre amarilla
b. Influenza
c. Malaria
d. Dengue
e. Enfermedad de Chagas

Respuesta correcta: d. Dengue

Explicación: Tiene las petequias, la trombopenia y la clínica de mialgias intensas y fiebre alta del dengue. Habitualmente no tiene anemia (la anemia orienta a malaria).

Fuente: Infectología, cuestionario 9.6, P18

Uso de antimicrobianos (7)

127. ¿Cuál de los siguientes antibióticos NO tiene cobertura para Pseudomona aureginosa?

a. Cefotaximo
b. Ticarcilina
c. Ciprofloxacino
d. Gentamicina
e. Imipenem

Respuesta correcta: a. Cefotaximo

Explicación: La Pseudomona aureginosa se caracteriza por ser resistente a muchos antibióticos. - De las cefalosporinas, solo algunas de tercera generación tienen acción antipseudomona: ceftazidima, cefoperazona y también las de cuarta generación: cefepime. Actualmente también se puede usar el cefiderocol (sexta generación). La ceftriazona y el cefotaximo no cubren Pseudomona. - La piperacilina y ticarcilina son penicilinas antipseudomona. Eso sí, generalmente se usan junto a un inhibidor de las betalactamasas, como el tazobactam o el ácido clavulánico. - Los carbapenémicos (meropenem e imipenem) son una buena opción, aunque el ertapenem no tiene buena cobertura contra esta bacteria. - Las quinolonas (ciprofloxacino, levofloxacino,) también la cubren bien. - Los aminoglicósidos cubren Pseudomona, aunque de los aminoglicósidos, los de elección contra dicha bacteria son la tobramicina y la amikacina.

Fuente: Infectología, cuestionario 9.1, P4

128. Una paciente adulta mayor, presenta simultáneamente una neumonía y una infección urinaria baja. Usted decide dejar tratamiento ambulatorio para ambas. De entre los medicamentos mencionados a continuación, ¿cuál es el más adecuado?

a. Clindamicina
b. Amoxicilina
c. Ciprofloxacino
d. Levofloxacino
e. Azitromicina

Respuesta correcta: d. Levofloxacino

Explicación: El levofloxacino cubre bien las ITU (es una quinolona) y además cubre a las neumonía (neumococo, haemophilus y atípicos), por lo que junto con el moxifloxacino se conocen como las "quinolonas respiratorias", aunque el moxifloxacino no suele usarse en el tratamiento de las ITU, siendo suficiente el espectro de acción del ciprofloxacino y levofloxacino. * Las cefalosporinas de segunda generación (cefuroximo) y de tercera generación (ceftriaxona y el cefotaximo) también cubren ambas. - La clindamicina no cubre ninguna. - La amoxicilina y la azitromicina no cubren ITU. - El ciprofloxacino no cubre neumonía.

Fuente: Infectología, cuestionario 9.1, P18

129. ¿Cuál de los siguientes tratamientos NO tiene cobertura para anaerobios?

a. Penicilina G
b. Moxifloxacino
c. Clindamicina
d. Metronidazol

e. Gentamicina

Respuesta correcta: e. Gentamicina

Explicación: La penicilina G en dosis altas cubre anaerobios. Pero por regla general cubre estreptococos. El moxifloxacino cubre Gram(+), Gram(-) y anaerobios. La clindamicina cubre Gram(+) y anaerobios. El metronidazol cubre anaerobios y protozoos. La gentamicina cubre Gram(-) y parcialmente a los Gram(+).

Fuente: Infectología, cuestionario 9.2, P8

130. ¿Cuál de los siguientes es el tratamiento de elección para una sepsis por Klebsiella BLEE (betalactamasa de espectro expandido)?

a. Cefotaximo
b. Cefoperazona
c. Cefepime
d. Imipenem
e. Levofloxacino

Respuesta correcta: d. Imipenem

Explicación: Los microorganismos BLEE se tratan preferentemente con carbapenémicos. BLEE significa que tienen betalactamasas capaces de degradar a las cefalosporinas, por lo que no sirve ninguna (opciones A, B y C). Debido a que para saber que es BLEE, se necesita un antibiograma, en la práctica, también es correcto tratar con otros antibióticos, a los que el antibiograma demuestre susceptibilidad.

Fuente: Infectología, cuestionario 9.3, P6

131. El metronidazol es un antibiótico capaz de tratar las infecciones causadas por:

a. Cocáceas Gram positivas
b. Bacilos Gram negativos
c. Histoparásitos como el Tripanosoma y el Plasmodium
d. Enteroparásitos unicelulares como la Entoameba y la Giardia
e. Mycobacterias

Respuesta correcta: d. Enteroparásitos unicelulares como la Entoameba y la Giardia

Explicación: El metronidazol cubre anaerobios y protozoos (amebas, giardiasis, tricomoniasis, balantidium, etc.).

Fuente: Infectología, cuestionario 9.3, P11

132. ¿Cuál de los siguientes tratamientos antibióticos NO tiene una buena cobertura para las enterobacterias?:

a. Metronidazol
b. Gentamicina
c. Ceftriaxona
d. Cefazolina
e. Levofloxacino

Respuesta correcta: a. Metronidazol

Explicación: El metronidazol no cubre gram negativos, sino solo anaerobios y protozoos.

Fuente: Infectología, cuestionario 9.3, P13

133. Identifique la asociación INCORRECTA entre la patología y el medicamento de elección:

a. Fiebre tifoidea – ciprofloxacino
b. Leptospirosis – vancomicina
c. Arañazo de gato – azitromicina
d. Brucelosis – doxiciclina
e. Escherichia coli - ciprofloxacino

Respuesta correcta: b. Leptospirosis – vancomicina

Explicación: Leptospirosis se trata con doxiciclina, azitromicina, amoxicilina o ceftriaxona. - La vancomicina, en cambio, sirve para las infecciones por SAMR (S. aureus meticilina-resistente), Neumococo resistente a penicilina, enterococo resistente a ampicilina y C. difficile resistente a metronidazol. - La fiebre tifoidea se trata con ciprofloxacino ya que no solo cura la enfermedad, sino que elimina la portación biliar, por lo que reduce la transmisión de la enfermedad. También se puede tratar con ceftriaxona. - La bartonelosis o enfermedad por arañazo de gato se trata con azitromicina u otro macrólido. - La brucelosis se trata con doxiciclina, rifampicina o con macrólidos (generalmente dos fármacos). - La Escherichia coli se trata generalmente con ciprofloxacino, aunque también responde a las cefalosporinas de todas las generaciones y a otros medicamentos con acción sobre Gram negativos (ej. aminoglicósidos).

Fuente: Infectología, cuestionario 9.4, P6

Prevención y aislamiento (2)

134. Identifique la asociación INCORRECTA entre la patología y el tipo de aislamiento que debe recibir:

a. Infección por estafilococo áureo meticilino resistente – Aislamiento de contacto
b. Infección por Clostridium difficile – Aislamiento de contacto
c. Varicela – Aislamiento de contacto
d. Sarampión – Aislamiento respiratorio
e. Influenza – Aislamiento de gotitas, en cohorte

Respuesta correcta: c. Varicela – Aislamiento de contacto

Explicación: Todos los paciente deben recibir precauciones estándar (lavado de manos antes y después de atenderlo y uso de guantes ante procedimientos en el que se verán expuestos a fluidos). Si hay infección por algún microorganismo es posible que requieran aislamientos, que son 3 tipos: - Aislamiento de contacto: uso de pechera y guantes incluso si no se entrará en contacto con fluidos y se destinan un fonendo, manguito de presión, etc. al paciente aislado de manera exclusiva. Los microorganismos resistentes a antibióticos y los gastrointestinales suelen recibir aislamiento de contacto. - Aislamiento de gotitas: a lo anterior se agrega que. al estar a menos de un metro de distancia del paciente, se debe usar mascarilla y la cama del paciente debe estar al menos a un metro de distancia de las demás (las gotitas avanzan un metro). En general casi todas las infecciones respiratorias y las meningitis se aíslan de esta forma (o con aislamiento respiratorio). - Aislamiento respiratorio: El uso de mascarilla se extiende a todo el cuarto del paciente, por lo que debe tener un cuarto exclusivo para él e idealmente debe estar equipado con un extractor de aire. Solo 3 enfermedades reciben este aislamiento: TBC, Sarampión y Varicela. La covid-19 se ha sumado a este tipo de aislamiento respiratorio, en algunas recomendaciones, mientras que otras mantienen el aislamiento de gotitas como el requerido para esta enfermedad. - Si hay un brote o varios casos, se pueden aislar todos juntos, ya que no hay riesgo de transmisión entre los que ya están enfermos. Esto se llama aislamiento de cohortes.

Fuente: Infectología, cuestionario 9.5, P6

135. Un paciente de 50 años es diagnosticado de tuberculosis, mediante baciloscopías, las que resultan positivas (Se solicitaron 4 y todas resultan positivas). Debido a que padece de comorbilidades y a su estado de desnutrición, se decide hospitalizar, para iniciar tratamiento. ¿Qué tipo de precauciones deben indicarse?

a. Precauciones estándar
b. Precauciones de contacto (aislamiento de contacto)
c. Precauciones de gotitas (aislamiento de gotitas)
d. Precauciones respiratorias (aislamiento respiratorio)
e. Ningún tipo de precaución, ya que la tuberculosis no es contagiosa entre personas

Respuesta correcta: d. Precauciones respiratorias (aislamiento respiratorio)

Explicación: Tuberculosis, varicela y sarampión son las 3 enfermedades que requieren aislamiento respiratorio, ya que se transmiten por microgotas. Por tanto, son patologías muy contagiosas.

Fuente: Infectología, cuestionario 9.6, P6

Hematología (108)

Anemias ferropénicas, microcíticas y de enfermedades crónicas (12)

1. Una paciente de 25 años, sin antecedentes de importancia, es diagnosticada de anemia ferropénica, con hematocrito de 30%, hemoglobina de 8,6 mg/dl y perfil de fierro compatible. Ella refiere reglas regulares y abundantes y su examen físico no aporta mayor información. La conducta más adecuada es:

a. Indicar aumento de la ingesta de carnes rojas (Ej: vacuno e hígado) y vegetales color verde oscuro (Ej: acelgas y espinacas)
b. Indicar sulfato ferroso vía oral y vitamina B12 vía intramuscular
c. Iniciar sulfato ferroso por vía oral e indicar uso de anticonceptivos orales
d. Solicitar colonoscopía
e. Indicar biopsia de médula ósea

Respuesta correcta: c. Iniciar sulfato ferroso por vía oral e indicar uso de anticonceptivos orales

Explicación: El tratamiento de la anemia ferropénica es el hierro oral (solo en la IRC es endovenoso). Además, en una mujer en edad fértil, no es necesario estudiarla, sino que basta con tratarla (en adulto mayor, se debe hacer colonoscopía y eventualmente endoscopía, en busca de la causa). Finalmente, se debe indicar anticonceptivos, para evitar la pérdida de hierro. - Cabe recordar que el estudio ante una sospecha de anemia (ej. palidez y fatiga) comienza con un hemograma. - Las pruebas relacionadas al hierro se pueden pedir simultáneamente al hemograma o después. - Es correcto solicitar solo ferritina o bien un perfil de hierro completo, con ferritina, transferrina o TIBC y porcentaje de saturación de esta última. - Una vez confirmada la anemia ferropénica se debe tratar y no requiere estudios cuando la causa es evidente (ej. mujer con reglas abundantes, enfermedad celíaca, etc.). Pero sí se debe estudiar con colonoscopía y endoscopía cuando queda duda del diagnóstico (ej. mayores de 50 años, mujeres postmenopáusicas, pacientes que no responden al tratamiento con hierro).

Fuente: Hematología, prueba 8 del 8 de mayo de 2024, P3

2. Una paciente de 50 años presenta un cuadro de astenia y adinamia de dos meses de evolución, asociada a palidez de piel y mucosas. Se solicita un hemograma, que demuestra anemia normocítica, con hematocrito de 28%, hemoglobina: 9,1 g/dl y VCM de 80 fl. Se solicita perfil de hierro, que muestra ferritina disminuida y transferrina elevada, con ferremia disminuida. La conducta más adecuada es:

a. Solicitar biopsia de médula ósea
b. Iniciar estudio, en busca de una enfermedad crónica, que explique la anemia
c. Iniciar sulfato ferroso oral hasta normalizar el perfil de fierro
d. Iniciar tratamiento con sulfato ferroso, vitamina B12 y folatos
e. Hospitalizar y tratar con transfusiones de glóbulos rojos

Respuesta correcta: c. Iniciar sulfato ferroso oral hasta normalizar el perfil de fierro

Explicación: Tiene una anemia ferropénica (suele ser microcítica, pero en este caso el VCM está normal, pero en el límite bajo). El perfil de hierro no deja dudas: ferritina baja y transferrina alta es lo característico. En la anemia de enfermedades crónicas, la ferritina está alta y la transferrina, baja. Vale la pena recalcar, que si fuera una mujer postmenopáusica o con sintomatología digestiva, no estaría de más hacer una colonoscopía, en busca de una causa que explique la ferropenia (ej. cáncer). Las transfusiones se reservan a los casos de anemia severa y muy sintomática.

Fuente: Hematología, prueba 3 del 8 de mayo de 2024, P4 · Hematología, prueba 6 del 5 de mayo de 2024, P14

3. Un paciente de 15 años presenta anemia crónica. En sus exámenes destaca un hemograma con anemia microcítica, con VCM de 66, con hematocrito de 33% y 5 millones de GR por mm3. Además, tiene ferritina ligeramente elevada. El diagnóstico de sospecha es:

a. Anemia drepanocítica (por células falciformes)
b. Talasemia
c. Anemia ferropénica
d. Microesferocitosis familiar
e. Anemia por enfermedades crónicas

Respuesta correcta: b. Talasemia

Explicación: Es una talasemia clásica: anemia microcítica (VCM menor a 80), con aumento del número de glóbulos rojos, más elevación de la ferritina. Si hubiese sido normocítica (VCM: 80 a 100), habría sido anemia por enfermedades crónicas. La anemia ferropénica es microcítica, pero con ferritina muy baja.

Fuente: Hematología, prueba 4 del 8 de mayo de 2024, P4

4. Un paciente de 15 años presenta anemia crónica. En sus exámenes destaca un hemograma con anemia microcítica, con VCM de 66, con hematocrito de 33% y 5 millones de GR por mm3. Además, tiene ferritina ligeramente elevada. El diagnóstico de sospecha es:

a. Microesferocitosis familiar
b. Anemia ferropénica
c. Anemia drepanocítica (por células falciformes)
d. Anemia por enfermedades crónicas
e. Talasemia

Respuesta correcta: e. Talasemia

Explicación: Es una talasemia clásica: anemia microcítica (VCM menor a 80), con aumento del número de glóbulos rojos, más elevación de la ferritina. Si hubiese sido normocítica (VCM: 80 a 100), habría sido anemia por enfermedades crónicas. La anemia ferropénica es microcítica, pero con ferritina muy baja.

Fuente: Hematología, prueba 4 del 5 de mayo de 2024, P4

5. Una paciente de 40 años presenta un cuadro de astenia y adinamia de dos meses de evolución, asociada a palidez de piel y mucosas. Se solicita un hemograma, que demuestra anemia microcítica, con hematocrito de 25%, hemoglobina: 7,8% y VCM de 68 fl. Se solicita perfil de hierro, que confirma ferropenia. La conducta más adecuada es:

a. Solicitar biopsia de médula ósea
b. Iniciar sulfato ferroso oral hasta normalizar el hematocrito
c. Iniciar sulfato ferroso oral hasta normalizar el perfil de fierro
d. Iniciar tratamiento con sulfato ferroso, vitamina B12 y folatos, hasta normalizar el VCM
e. Hospitalizar y tratar con transfusiones de glóbulos rojos

Respuesta correcta: c. Iniciar sulfato ferroso oral hasta normalizar el perfil de fierro

Explicación: El tratamiento de la anemia ferropénica es hierro oral hasta normalizar la ferritina (depósitos de hierro). La hemoglobina está bastante baja, pero para que fuera indicación de transfusión debería ser tratarse de una anemia severamente sintomática: ej. disnea de esfuerzos invalidante, descompensación de cardiopatías, isquemia cardíaca, etc. Recordar que por regla general solo se transfunden las anemias muy sintomáticas y no hay un corte de hemoglobina estricto (aunque bajo 7 g/dl suelen requerir

transfusión). Además, se debe buscar una causa de la anemia (ej. pérdidas por menstruaciones abundantes) y, si no se identifica una causa clara, se debe buscar activamente la causa con colonoscopía y endoscopía digestiva alta.

Fuente: Hematología, prueba 7 del 8 de mayo de 2024, P4

6. Una paciente de 50 años, presenta un cuadro de astenia y palidez, por lo que se realiza un hemograma que muestra hemoglobina: 8,5 mg/dl, VCM: 68 fl, blancos: 6.400 x mm3, plaquetas: 490.000 por mm3. El diagnóstico más probable es:

a. Leucemia mieloide crónica
b. Anemia por déficit de vitamina B12
c. Trombocitosis esencial
d. Anemia por enfermedades crónicas
e. Anemia ferropénica

Respuesta correcta: e. Anemia ferropénica

Explicación: Es una ferropenia clásica: anemia microcítica (VCM menor a 80), con trombocitosis reactiva (trombocitosis corresponde a plaquetas mayores a 450.000 por mm3, aunque en la ferropenia pueden estar mucho más elevadas; aunque no es del todo correcto, se dice que "la médula no tiene hierro para hacer glóbulos rojos, entonces hace plaquetas"). - La LMC tendría leucocitosis (de predominio neutrofílico y con desviación izquierda, más trobocitosis). - El déficit de vitamina B12 tendría pancitopenia (y, por tanto, plaquetopenia) más VCM muy elevado. - La trombocitosis esencial no tendría anemia. - La anemia por enfermedades crónicas suele ser normocítica.

Fuente: Hematología, prueba 2 del 8 de mayo de 2024, P5

7. Un niño de 3 meses, asintomático, alimentado con leche materna, presenta hemograma con hemoglobina de 9,2 g/dl, sin alteración de las otras series de células sanguíneas. La conducta más adecuada es:

a. Solicitar biopsia de médula ósea
b. Solicitar perfil de hierro, niveles de vitamina B12 y folatos
c. Iniciar tratamiento con hierro oral
d. Observar evolución
e. Solicitar pruebas de screening para talasemias

Respuesta correcta: d. Observar evolución

Explicación: La anemia en niños se define como hemoglobina menor a p3 para la edad y sexo (menor a 2 desviaciones estándar). A los 3 meses, es normal tener hemoglobina hasta 9 g/dl, por lo que está normal. A esto se le suele llamar “anemia fisiológica”, que ocurre entre los 2 y 6 meses de edad (hasta 9 meses máximo), por el recambio de Hb fetal a Hb adulta. Por tanto, el diagnóstico es "sano" o "anemia fisiológica de la infancia". Se observa. Si la hemoglobina es menor a 9 g/dl o si hay signos de hemólisis (ictericia, orinas oscuras, LDH elevada, reticulocitos altos, etc.), se deben estudiar las causas patológicas. - Después de los 6 meses, lo más frecuente, en cambio, es la anemia ferropénica, en especial en niños en lactancia materna exclusiva y sin suplementos de hierro.

Fuente: Hematología, prueba 6 del 5 de mayo de 2024, P7

8. Un paciente de 60 años presenta anemia, con Hcto: 31% y VCM: 90 fl. Se solicita un perfil de hierro, que muestra ferremia baja, ferritina elevada y transferrina baja. El diagnóstico más probable es:

a. Anemia ferropénica

b. Talasemia
c. Anemia sideroblástica
d. Anemia de enfermedades crónicas
e. Asociación de anemia ferropénica y anemia por déficit de vitamina B12

Respuesta correcta: d. Anemia de enfermedades crónicas

Explicación: Es una anemia por enfermedades crónica clásica: VCM normal, ferritina alta y transferrina baja. La ferremia puede estar normal o baja. La ferropenia tiene VCM disminuido, ferritina baja y transferrina elevada. La talasemia tiene VCM disminuido y ferritina habitualmente alta. La anemia sideroblástica es un trastorno rarísimo, genético o asociado a mielodisplasias, en que hay anemia microcítica y sideroblastos (similar a glóbulo rojo, pero nucleado y con acúmulos de hierro en el citoplasma, en forma de anillo, alrededor del núcleo)

Fuente: Hematología, prueba 8 del 8 de mayo de 2024, P7

9. La anemia ferropénica se caracteriza por todo lo siguiente, EXCEPTO:

a. Anisocitosis
b. Transferrina disminuida
c. Microcitosis
d. Hipocromía
e. Trombocitosis reactiva

Respuesta correcta: b. Transferrina disminuida

Explicación: El perfil de hierro de la ferropenia muestra ferritina baja, con transferrina alta y ferremia baja. Las demás opciones son características de la anemia ferropénica.

Fuente: Hematología, prueba 1 del 8 de mayo de 2024, P8

10. Una paciente de 50 años, presenta un cuadro de astenia y palidez, por lo que se realiza un hemograma que muestra hemoglobina: 8,5 mg/dl, VCM: 68 fl, blancos: 6.400 x mm3, plaquetas: 490.000 por mm3. El diagnóstico más probable es:

a. Leucemia mieloide crónica
b. Anemia por enfermedades crónicas
c. Trombocitosis esencial
d. Anemia ferropénica
e. Anemia por déficit de vitamina B12

Respuesta correcta: d. Anemia ferropénica

Explicación: Es una ferropenia clásica: anemia microcítica (VCM menor a 80), con trombocitosis reactiva (trombocitosis corresponde a plaquetas mayores a 450.000 por mm3, aunque en la ferropenia pueden estar mucho más elevadas; aunque no es del todo correcto, se dice que "la médula no tiene hierro para hacer glóbulos rojos, entonces hace plaquetas"). - La LMC tendría leucocitosis (de predominio neutrofílico y con desviación izquierda, más trobocitosis). - El déficit de vitamina B12 tendría pancitopenia (y, por tanto, plaquetopenia) más VCM muy elevado. - La trombocitosis esencial no tendría anemia. - La anemia por enfermedades crónicas suele ser normocítica.

Fuente: Hematología, prueba 4 del 8 de mayo de 2024, P15

11. Un niño de 10 meses, asintomático, alimentado con leche materna y una comida, presenta anemia con hemoglobina de 9,2 g/dl, sin alteración de las otras series de células sanguíneas y con volumen corpuscular medio de 75 fl. La conducta más adecuada es:

a. Solicitar biopsia de médula ósea
b. Solicitar perfil de hierro, niveles de vitamina B12 y folatos
c. Iniciar tratamiento con hierro oral
d. Solicitar prueba de Coombs
e. Solicitar pruebas de screening para talasemias

Respuesta correcta: c. Iniciar tratamiento con hierro oral

Explicación: Lo poco que hay que saber de anemia en niños es: 1. Se diagnostica como la hemoglobina < 2 DS para el sexo y la edad, equivalente a <p3. 2. Después del primer mes, la hemoglobina empieza a bajar rápidamente. El nadir se suele producirse entre los 2 y 6 meses, durando con valores bajos hasta máximo los 9 meses. Habitualmente baja a niveles de 10-11 g/dl, pero es normal que baje la hemoglobina hasta máximo 9 g/dl, lo que se conoce como "anemia fisiológica de la infancia". 3. Niveles bajo 9 g/dl se consideran patológicos. 4. Después de los 6-9 meses, suelen estar sobre 9,5 g/dl y la anemia más frecuente es la ferropénica (especialmente en niños alimentados solo con lactancia materna) y, a menos que parezca evidentemente otra causa, la conducta es simplemente tratarla con hierro oral. En este caso, el VCM está bajo, por lo que lo correcto es la prueba terapéutica con hierro. Si el frotis o la clínica sugieren otras causas, se deben estudiar.

Fuente: Hematología, prueba 4 del 8 de mayo de 2024, P16 · Hematología, prueba 3 del 8 de mayo de 2024, P17

12. Paciente de 45 años, consulta porque le indicaron que padecía de anemia. El hemograma constata recuento de blancos y plaquetas normales, Hcto: 33%, Hb: 11 mg/dl, VCM: 70. En el frotis se aprecia anisocitosis con aumento del índice de dispersión eritrocítica. El diagnóstico más probable es:

a. Talasemia
b. Anemia ferropénica
c. Anemia de enfermedades crónicas
d. Anemia hemolítica crónica
e. Hemocromatosis

Respuesta correcta: b. Anemia ferropénica

Explicación: La anemia ferropénica se caracteriza por se microcítica (VCM menor a 80) y por tener anisocitosis, es decir, células de distinto tamaño. La talasemia también es microcítica, pero hay isocitosis (todos los glóbulos rojos son del mismo tamaño). La anemia por enfermedades crónicas tiene VCM normal (normocítica). La anemia hemolítica suele tener VCM elevado, porque os reticulocitos son más grandes que los GR promedio. La hemocromatosis no tiene anemia, sino que es una enfermedad de depósito de hierro, que produce daño hepático, cardíaco, diabetes e hiperpigmentación.

Fuente: Hematología, prueba 7 del 8 de mayo de 2024, P16

Anemias macrocíticas y megaloblásticas (5)

13. Un paciente de 20 años, diagnosticado de malabsorción intestinal por enfermedad de Cröhn, consulta por astenia. Al examen físico se aprecia palidez, por lo que se solicita hemograma que demuestra hematocrito: 23%, hemoglobina: 7,6 g/dl, VCM: 111 ft, blancos: 3.200 x mm3, con fórmula diferencial normal y plaquetas: 89.000 x mm3. Se constata aumento de la LDH plasmática y de la bilirrubina, de predominio indirecto y el índice reticulocitario es de 0,2. El diagnóstico más probable es:

a. Anemia hemolítica
b. Anemia por enfermedades crónicas
c. Anemia por aplasia medular
d. Anemia ferropriva
e. Anemia por déficit de vitamina B12

Respuesta correcta: e. Anemia por déficit de vitamina B12

Explicación: El antecedente de enfermedad de Cröhn puede producir anemia por enfermedades crónicas. La malabsorción puede producir anemia ferropriva y por déficit de vitamina B12. Sin embargo, los exámenes son muy sugerentes de una anemia por déficit de B12, al tener una pancitopenia, con macrocitosis marcada (VCM mayor a 100 es macrocitosis y mayor a 108 sugiere fuertemente déficit de B12). El déficit de B12 tiene caída en el índice reticulocitario (<2 es una anemia arregenerativa), al igual que la mayoría de las anemias, con la única excepción de las hemólisis y las hemorragias agudas (las hemorragias crónicas hacen ferropenia). Al igual que la anemia hemolítica, la anemia por déficit de B12 también produce elevación de la LDH y bilirrubina indirecta. La anemia ferropénica también es frecuente en las enfermedades inflamatorias intestinales, por las pérdidas digestivas de sangre, pero suele ser microcítica (VCM menor a 80).

Fuente: Hematología, prueba 5 del 8 de mayo de 2024, P3

14. Un paciente de 65 años, es diagnosticado de cáncer gástrico, por lo que se le realiza una gastrectomía total y posterior quimioterapia. Evoluciona con baja de peso y anemia. Su hemograma muestra un hematocrito de 24%, hemoglobina de 8,7 g/dl, plaquetas: 80.000 y blancos: 3.200 por mm3. El volumen corpuscular medio es 118 fl y la concentración corpuscular media de hemoglobina es 36 pg. El diagnóstico más probable es:

a. Aplasia medular
b. Mieloptisis
c. Anemia ferropénica
d. Anemia por enfermedades crónica
e. Anemia por déficit de vitamina B12

Respuesta correcta: e. Anemia por déficit de vitamina B12

Explicación: Tiene una pancitopenia, con anemia megaloblástica (VCM mayor a 108), por lo que es un clásico déficit de B12. El antecedente de gastrectomía, lo hace aun más probable, dado que en el estómago se produce el factor intrínseco, necesario para la absorción de la B12.

Fuente: Hematología, prueba 7 del 8 de mayo de 2024, P6

15. Una paciente de 60 años presenta astenia y palidez. Se decide realizar un hemograma, que muestra pancitopenia, con hematocrito. 27%, Hb: 10 g/dl, VCM: 120, blancos: 3.000 por mm3, plaquetas: 90.000 por mm3. El frotis muestra neutrófilos con núcleo hipersegmentado. El diagnóstico más probable es:

a. Mielodisplasia

b. Leucemia mieloide crónica
c. Anemia perniciosa
d. Anemia hemolítica
e. Mieloma múltiple

Respuesta correcta: c. Anemia perniciosa

Explicación: Es una anemia por déficit de B12 clásica: pancitopenia, con VCM mayor a 108 (anemia megaloblástica) e hipersementación del núcleo de los neutrófilos. La anemia perniciosa es la causa más frecuente de déficit de B12. Es una enfermedad autoinmune, con anticuerpos en contra de las células parietales gástricas (en específico contra la bomba de protones que es la proteína que inhibe el omeprazol y demás IBP). Las células parietales producen el ácido clorhídrico, pero también el factor intrínseco, necesario para la absorción de la vitamina B12. Se trata con vitamina B12 inyectable, ya que, a diferencia de otras causas de anemia por déficit de B12, en este caso hay un problema de la absorción. Se asocia a cáncer gástrico, por lo que se suele estudiar con endoscopía digestiva alta.

Fuente: Hematología, prueba 1 del 8 de mayo de 2024, P9

16. Una paciente de 60 años, gastrectomizada por cáncer gástrico, presenta un cuadro de astenia. Al examen físico está pálida y algo ictérica, con RR2T sin soplos, MP(+) sin ruidos agregados, abdomen blando, depresible, sin visceromegalia. Se solicita un hemograma que muestra anemia con Hcto: 22%, VCM: 120 ft, reticulocitos: 0,02%, plaquetas: 100.000 por mm3, blancos: 3.500 por mm3, LDH: 450 UI/L, bilirrubina: 3,2 mg/dl, de predominio indirecto. El diagnóstico más probable es:

a. Mielodisplasia
b. Déficit de hierro
c. Mieloptisis
d. Déficit de vitamina B12
e. Mielodisplasia

Respuesta correcta: d. Déficit de vitamina B12

Explicación: El antecedente de gastrectomía sugiere déficit de B12 (por la falta de factor intrínseco). Además, la pancitopenia con VCM elevado es muy sugerente de déficit de B12. La elevación de la LDH y de la bilirrubina indirecta es característica de la anemia hemolítica, pero también se suele ver en el déficit de B12, porque hay una mielopoyesis inefectiva, con destrucción celular en la médula. Sin embargo, la anemia hemolítica es regenerativa (con elevación de los reticulocitos). En cambio, el déficit de B12 tiene reticulocitos muy bajos, como en este caso.

Fuente: Hematología, prueba 2 del 8 de mayo de 2024, P9

17. Paciente de 60 años, operado por cáncer gástrico, hace 3 años, consulta por astenia, adinamia y debilidad. Al examen pálido, con escasas petequias en extremidades superiores. El hemograma muestra Hematocrito: 23%, VCM: 120, blancos: 3.000, con fórmula diferencial normal, plaquetas: 85.000. Al frotis se aprecia macrocitosis, macroplaquetas y aumento de la segmentación del núcleo de los neutrófilos. El examen más adecuado para continuar el estudio etiológico es:

a. Biopsia de médula ósea
b. Radiografía de calota
c. Electroforesis de proteínas en sangre y orina
d. Niveles de vitamina B12
e. Citometría de flujo en sangre periférica

Respuesta correcta: d. Niveles de vitamina B12

Explicación: Es un déficit de B12 clásico. El antecedente de gastrectomía, indica la falta de factor intrínseco, necesario para la absorción de la B12. El hemograma ahí descrito es característico: pancitopenia con anemia megaloblástica (VCM > 108) e hipersegmentación de los neutrófilos. Con frecuencia eleva la LDH y bilirrubina indirecta, pero se diferencia de la hemólisis, en que esta última tiene elevación de reticulocitos y, en cambio, el déficit de B12 es una anemia arregenerativa.

Fuente: Hematología, prueba 6 del 5 de mayo de 2024, P9

Anemias hemolíticas (6)

18. Un paciente presenta anemia, con hematocrito: 25%, VCM: 110 fl, plaquetas: 250.000 por mm3, blancos: 6.000 por mm3, reticulocitos: 10%. Además, se constata elevación de la bilirrubina plasmática de predominio indirecto y de la LDH (lactato deshidrogenasa). El diagnóstico más probable es:

a. Anemia hemolítica
b. Anemia por enfermedades crónicas
c. Mielodisplasia
d. Anemia perniciosa
e. Anemia por déficit de folatos

Respuesta correcta: a. Anemia hemolítica

Explicación: Dado que los reticulocitos están elevados, es una anemia hemolítica (recordar que solo la hemólisis y las hemorragias recientes son anemias regenerativas, es decir, tienen elevado el índice reticulocitario). La hemólisis además eleva la bilirrubina indirecta, la LDH y, además, puede elevar el VCM, porque los reticulocitos son más grandes que los glóbulos rojos promedio y elevan el VCM. Si hubiese tenido los reticulocitos bajos, el diagnóstico sería déficit de B12, por la elevación del VCM y porque la falta de B12 también eleva la bilirrubina y la LDH (por la eritropoyesis inefectiva a nivel de la médula ósea).

Fuente: Hematología, prueba 8 del 8 de mayo de 2024, P4

19. ¿Cuál de las siguientes alteraciones es más probable es un paciente con anemia hemolítica?

a. Disminución de los reticulocitos
b. Aumento de la bilirrubina directa
c. Aumento de la lactato deshidrogenasa plasmática
d. Disminución del volumen corpuscular medio
e. Alargamiento del tiempo de tromboplastina parcial activado

Respuesta correcta: c. Aumento de la lactato deshidrogenasa plasmática

Explicación: La anemia hemolítica tiene aumento de los reticulocitos (es regenerativa), aumento de la bilirrubina indirecta, aumento de la LDH, aumento del VCM (por los reticulocitos) y no afecta los tiempos de coagulación.

Fuente: Hematología, prueba 3 del 8 de mayo de 2024, P5

20. Una paciente presenta un cuadro de anemia, con marcada elevación de los reticulocitos y presencia de esquistocitos. ¿Qué examen es más adecuado para el estudio de esta paciente?

a. Prueba de Coombs directo
b. Niveles de vitamina B12
c. Biopsia de médula ósea

d. Ferritina y transferrina plasmáticas
e. Tiempo de sangría

Respuesta correcta: a. Prueba de Coombs directo

Explicación: Tiene una anemia hemolítica: elevación de reticulocitos (regenerativa) y presencia de esquistocitos (membranas de los glóbulos rojos hemolizados). Se solicita prueba de Coombs directo, para buscar la causa autoinmune: si está positiva, se debe a anticuerpos contra los glóbulos rojos; si está negativa, se debe a otras causas de hemólisis.

Fuente: Hematología, prueba 7 del 8 de mayo de 2024, P5

21. Una paciente de 69 años, diagnosticada de una leucemia linfática crónica, consulta por marcado malestar general, asociado a orinas oscuras y dolor abdominal. Al examen físico presenta palidez e ictericia de piel y mucosas. Se solicitan exámenes que demuestran Hcto: 21%, hemoglobina: 7 g/dl, blancos: 28.000 por mm3, plaquetas: 150.000, bilirrubina plasmática: 5,6 mg/dl, con bilirrubina directa: 0,3 mg/dl y bilirrubina indirecta: 5,3 mg/dl, LDH: 1.200 UI/L. ¿Qué examen es más adecuado para proseguir el estudio de esta paciente?

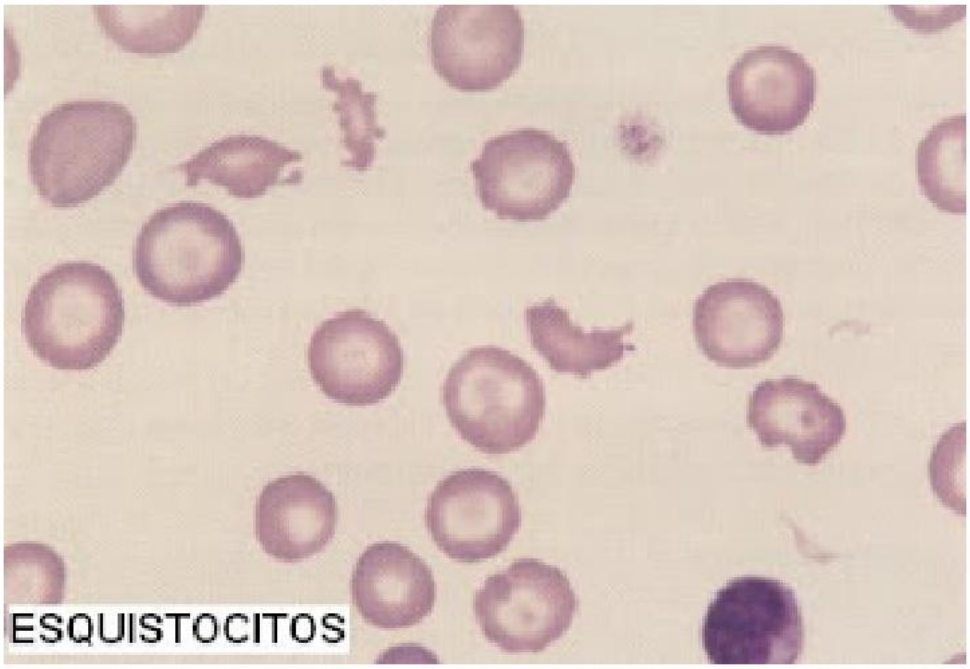
a. Solicitar biopsia de médula ósea
b. Solicitar niveles plasmáticos de vitamina B12
c. Solicitar niveles plasmáticos de ácido metil malónico y de homocisteína
d. Solicitar electroforesis de proteínas y radiografía de cráneo
e. Solicitar prueba de Coombs directo y frotis sanguíneo

Respuesta correcta: e. Solicitar prueba de Coombs directo y frotis sanguíneo

Explicación: Es una anemia hemolítica autoinmune (AHAI), en contexto de una LLC. La prueba de Coombs permite confirmar la AHAI y el frotis permite ver los esquistocitos. La AHAI se asocia a algunos cánceres hematológicos y también a otras enfermedades autoinmunes, como el lupus. En este caso, la sugieren la hiperbilirrubinemia indirecta, la LDH muy elevada y la clínica de dolor abdominal y orinas oscuras. Vale la pena mencionar que la orina oscura se debe a la hemoglobinuria y no a la coluria, porque la coluria es un signo asociado a ictericias de predominio directo. Vale la pena saber que la LLC no solo produce anemia y trombopenia por la ocupación medular, sino que también porque se asocia a procesos autoinmunes (AHAI y PTI secundarios a LLC).

Fuente: Hematología, prueba 1 del 8 de mayo de 2024, P6

22. Los esquistocitos son muy sugerentes de:



a. Hemorragias agudas
b. Asplenia
c. Déficit vitamina B12
d. Leucemia
e. Hemólisis

Respuesta correcta: e. Hemólisis

Explicación: Los esquistocitos son característicos de la hemólisis intravascular: son las membranas del glóbulo rojo hemolizado. Las hemorragias agudas tienen elevación de los reticulocitos. La asplenia tiene cuerpos de Howell Jolly. El déficit de vitamina B12 tiene macrocitosis, anisocitosis, pancitopenia e hipersegmentación del núcleo de los neutrófilos. La leucemia tiene leucocitosis, con leucocitos atípicos. En las leucemias agudas suele haber elevación de los blastos y si son de tipo mieloide, es clásico que tengan bastones de Auer. En la leucemia linfática crónica se ven las sombras de Gumprecht. Por cultura general, se muestran los esquistocitos (fuente: https://ficherodehematologia.com):

Fuente: Hematología, prueba 2 del 8 de mayo de 2024, P7

23. ¿Cuál de las siguientes alteraciones es MENOS probable es un paciente con anemia hemolítica autoinmune?

a. Presencia de esquistocitos
b. Aumento de la bilirrubina indirecta
c. Aumento de la lactato deshidrogenasa plasmática
d. Prueba de Coombs directa positiva
e. Disminución de los eritrobastos y otras formas inmaduras de glóbulos rojos, en la médula ósea

Respuesta correcta: e. Disminución de los eritrobastos y otras formas inmaduras de glóbulos rojos, en la médula ósea

Explicación: La anemia hemolítica se caracteriza por tener esquistocitos y/o fragmentocitos (restos del glóbulo rojo hemolizado), elevar la bilirrubina indirecta y la LDH. Además, por ser regenerativa, aumentan las formas inmaduras de glóbulos rojos: reticulocitos e incluso policromatófilos o eritroblastos, en los casos más graves. La prueba de Coombs directa solo está positiva en las hemólisis de causa inmune y no en todas las anemias hemolíticas.

Fuente: Hematología, prueba 6 del 5 de mayo de 2024, P15

Mielodisplasia, aplasia y pancitopenia (7)

24. Un paciente de 69 años presenta astenia y palidez, por lo que se realiza un hemograma, que muestra hemoglobina: 8,6 g/dl, hematocrito: 26%, VCM: 105 ft, plaquetas: 70.000 por mm3, blancos: 3.100 por mm3, con fórmula diferencial normal. Su examen físico no aporta mayor información. El diagnóstico más probable es:

a. Mielodisplasia
b. Aplasia medular
c. Déficit de vitamina B12
d. Mieloma múltiple
e. Leucemia

Respuesta correcta: a. Mielodisplasia

Explicación: Es una mielodisplasia clásica: pancitopenia, en un adulto mayor (promedio 70 años), con VCM normal o elevado (habitualmente entre 100 y 108). El diagnóstico exige 1. las citopenias en sangre periférica y 2. una biopsia de médula ósea que muestre displasias (algunos agregan que haya menos de 20% de blastos, para que no sea una leucemia aguda, aunque las mielodisplasias pueden evolucionar a una LMA). El tratamiento suele ser la observación, la terapia transfusional de soporte (anemias y trombopenias severas), el manejo de las infecciones (debidas la leucopenia) y, en los casos más avanzados, la quimioterapia y manejo con anticuerpos monoclonales (cuyos nombres no deben ser aprendidos) y, como última línea, el trasplante de médula ósea. - La aplasia también tendría pancitopenia, pero con VCM normal y se suele presentar en edades más tempranas. Suele ser autoinmune. El déficit de B12 también produce pancitopenia, pero con VCM habitualmente superior a 108. Mieloma múltiple y leucemia aguda sí pueden tener pancitopenia, pero suelen tener otro tipo de síntomas.

Fuente: Hematología, prueba 1 del 8 de mayo de 2024, P3

25. Un paciente de 70 años consulta por astenia. Al examen físico se encuentra pálido, sin otras alteraciones, por lo que se solicita un hemograma que muestra Hematocrito: 27%, hemoglobina: 9 g/dl, VCM: 103 fl, plaquetas: 60.000 x mm3, blancos: 2.500 x mm3, con fórmula diferencial normal. Se inicia tratamiento con vitamina B12 y folatos por vía parenteral y se controla 3 meses después, sin presentar mejoría. El diagnóstico más probable es:

a. Mielofibrosis
b. Mieloma múltiple
c. Aplasia medular
d. Anemia perniciosa
e. Mielodisplasia

Respuesta correcta: e. Mielodisplasia

Explicación: Es una mielodisplasia clásica: adulto mayor con pancitopenia, VCM elevado y anemia refractaria al tratamiento.

Fuente: Hematología, prueba 8 del 8 de mayo de 2024, P6

26. Un paciente de 70 años se realiza un hemograma, que muestra anemia con hematocrito de 30%, Hemoglobina de 10 g/dl, VCM: 101 fl, VHS: 30 mm/h, blancos: 3.000 por mm3 y plaquetas: 90.000 por mm3. Se iniciar tratamiento con vitaminas del complejo B y se controla un mes después, persistiendo con un hemograma muy similar. La conducta más adecuada es:

a. Mantener el tratamiento y observar evolución
b. Iniciar corticoides orales
c. Solicitar perfil de hierro
d. Solicitar estudio de médula ósea
e. Solicitar niveles de ácido metilmalónico y homocisteína

Respuesta correcta: d. Solicitar estudio de médula ósea

Explicación: Se puede enfrentar de dos formas: 1. Es una pancitopenia y por tanto, se estudia con biopsia de médula ósea. 2. Se sospecha una mielodisplasia (adulto mayor con pancitopenia, elevación del VCM y ausencia de respuesta al tratamiento), por lo que también se debe hacer la biopsia de médula ósea.

Fuente: Hematología, prueba 7 del 8 de mayo de 2024, P7

27. Un paciente de 65 años presenta hemograma con hemoglobina: 9,6 g/dl, VCM: 106, plaquetas: 150.000 x mm3 y blancos: 4.100 x mm3. Le indican vitamina B12 y folatos, los que recibe por 4 meses. Se controla un nuevo hemograma que presenta valores similares. El diagnóstico de sospecha es:

a. Mieloma
b. Leucemia aguda
c. Mielodisplasia
d. Anemia por enfermedades crónicas
e. Talasemia

Respuesta correcta: c. Mielodisplasia

Explicación: Es una mielodisplasia clásica: adulto mayor con pancitopenia y VCM elevado (puede estar normal). También se suele presentar como un adulto mayor con anemia refractaria a tratamiento. En este caso se conjugan ambas presentaciones. Suele ser asintomática en los estadios iniciales y manifestarse como síntomas de insuficiencia medular, a medida que avanza (infecciones, astenia y otros síntomas de anemia, petequias y equimosis). El diagnóstico se confirma con la biopsia de médula ósea, que muestra las displasias celulares características (citopenias + displasias, sin cumplir criterios de leucemia). Se suele observar y se da terapia de soporte (antibióticos y transfusiones si hay complicaciones de insuficiencia medular) y luego se trata con distintas quimioterapias, dependiendo de las mutaciones que se identifiquen. El único tratamiento curativo es el trasplante de médula ósea, que se reserva a los casos avanzados y que tienen un donante compatible.

Fuente: Hematología, prueba 3 del 8 de mayo de 2024, P15

28. Un paciente de 65 años, consulta por anemia. Al examen físico se constata palidez, y algunas petequias en las extremidades inferiores. Su examen físico no aporta mayor información. Se solicita un hemograma, que muestra Hematocrito: 25%, plaquetas: 20.000 por mm3 y blancos: 2.700 por mm, VCM: 108, VHS: 24 mm/h. Además, se solicita un perfil bioquímico, que destaca LDH elevada. Su recuento de reticulocitos es de 0,5% y sus niveles plasmáticos de ácido fólico y vitamina B12 están normales. El diagnóstico más probable es:

a. Mieloma múltiple

b. Mielofibrosis
c. Leucemia
d. Mielodisplasia
e. Anemia perniciosa

Respuesta correcta: d. Mielodisplasia

Explicación: Es una pregunta difícil. Tiene una pancitopenia, con elevación del VCM y de la LDH, lo que es compatible con una mielodisplasia. Sin embargo, también es compatible con un déficit de vitamina B12 (anemia perniciosa), pero esta causa se descartó, porque los niveles de B12 están normales. Vale la pena recordar que la LDH se eleva no solo en las hemólisis, sino en cualquier causa de mielopoyesis inefectiva (déficit de B12, mielodisplasia, leucemia) y, la verdad, se eleva con cualquier cosa, siendo de las pruebas menos específicas que existen. No es un mieloma, porque la VHS está apenas elevada (en el mieloma suele estar sobre 50 o incluso 100 mm/h) y le faltan los dolores óseos y el resto de las alteraciones del mieloma múltiple (falla renal, hipercalcemia, hiperproteinemia, etc).

Fuente: Hematología, prueba 6 del 5 de mayo de 2024, P16

29. Un paciente de 40 años presenta astenia, por lo que se solicita un hemograma que muestra hematocrito: 20%, hemoglobina: 6,5%, plaquetas: 32.000 por mm3, blancos, 3.200, con 55% de linfocitos, 15% de monocitos y 30% de neutrófilos. La conducta más adecuada es:

a. Iniciar tratamiento con sulfato ferroso, folatos y vitamina B12 y controlar ambulatoriamente
b. Iniciar tratamiento con corticoides orales
c. Solicitar electroforesis de proteínas
d. Solicitar biopsia de médula ósea
e. Solicitar niveles plasmáticos de vitamina B12

Respuesta correcta: d. Solicitar biopsia de médula ósea

Explicación: Tiene una pancitopenia, sin mucha más información. Las pancitopenias se estudian con biopsia de médula ósea. La única excepción es cuando el cuadro es muy sugerente de un déficit de B12 (ej. antecedente de cirugía gástrica con pancitopenia y marcada elevación del VCM), en que se primero se solicitan los niveles de B12.

Fuente: Hematología, prueba 6 del 5 de mayo de 2024, P18

30. Paciente de 60 años, consulta por astenia, adinamia e infecciones a repetición. Al examen pálido, con escasas petequias en extremidades superiores. El hemograma muestra Hematocrito: 23%, blancos: 3.000, con fórmula diferencial normal, plaquetas: 45.000. El examen más adecuado para continuar el estudio etiológico es:

a. Biopsia de médula ósea
b. Radiografía de calota
c. Electroforesis de proteínas en sangre y orina
d. Cinética de hierro y niveles de vitamina B12
e. Citometría de flujo en sangre periférica

Respuesta correcta: a. Biopsia de médula ósea

Explicación: Tiene una pancitopenia, sin mucha más información, por lo que se debe estudiar con biopsia de médula ósea, ya que diferencia las principales causas (mielodisplasia, aplasia, mieloma, mieloptisis, mielofibrosis, leucemias agudas). La única excepción, es cuando la clínica y hemograma sugieren muy

fuertemente un déficit de B12 (VCM elevado, hipersegmentación de los neutrófilos, antecedente de cirugía gástrica, etc.), en que se debe solicitar primeramente niveles de B12.

Fuente: Hematología, prueba 3 del 8 de mayo de 2024, P19

Leucemias agudas (5)

31. La segunda causa de muerte en la edad pediátrica es el cáncer. ¿Cuál es el tipo de cáncer más frecuente en esta edad (menores de 15 años)?

a. Leucemia linfática aguda
b. Leucemia linfática crónica
c. Leucemia mieloide aguda
d. Leucemia mieloide crónica
e. Linfoma

Respuesta correcta: a. Leucemia linfática aguda

Explicación: La LLA es el cáncer más frecuente de la infancia. Afortunadamente, las quimioterapias actuales permiten la curación de cerca del 90% de los casos. En los adolescentes, en cambio, el cáncer más frecuente es el linfoma de Hodgkin. Eso sí, en algunos estudios en otros países, aparecen más frecuentes los cánceres del sistema nervioso.

Fuente: Hematología, prueba 6 del 5 de mayo de 2024, P1

32. Un niño de 8 años presenta fiebre y malestar general de dos semanas de evolución. Al examen se aprecia pálido, con algunas equimosis y petequias en las extremidades. Además, se palpa esplenomegalia moderada. El diagnóstico más probable es:

a. Púrpura trombocitopénico trombótico
b. Púrpura trombocitopénico inmune
c. Leucemia mieloide crónica
d. Linfoma no Hodgkin
e. Leucemia linfática aguda

Respuesta correcta: e. Leucemia linfática aguda

Explicación: Si bien las petequias y equimosis son compatibles con una PTI (púrpura trombocitopénica trombótica), la fiebre, palidez y esplenomegalia sugieren una leucemia, la que debe ser aguda, por el tiempo de evolución. La leucemia aguda más frecuente de la infancia es la LLA (leucemia linfática aguda). La PTT (púrpura trombocitopénica trombótica) tiene una presentación caracterizada por insuficiencia renal aguda, con plaquetopenia y anemia hemolítica, más compromiso del sistema nervioso central y periférico (similar al SHU de los niños). El linfoma se presenta con adenopatías y suele no tener petequias ni esplenomegalia. Los síntomas B (fiebre, baja de peso y sudoración nocturna) son clásicos del linfoma de Hodgkin, pero, en realidad se presentan en los demás linfomas, leucemias, infecciones como la tuberculosis y enfermedades inflamatorias como el lupus.

Fuente: Hematología, prueba 8 del 8 de mayo de 2024, P1

33. Un paciente de 40 años consulta por un cuadro de 3 semanas de evolución de malestar general, dolores óseos y aparición de lesiones en la piel. Al examen físico se constatan petequias y equimosis generalizadas, palidez de mucosas y esplenomegalia. El diagnóstico más probable es:

a. Púrpura trombocitopénico inmune
b. Púrpura trombocitopénico trombótico

c. Linfoma
d. Leucemia
e. Mieloma

Respuesta correcta: d. Leucemia

Explicación: Es una leucemia aguda (LLA: leucemia linfática aguda o LMA: leucemia mieloide aguda): dolores óseos, síntomas de insuficiencia medular (astenia, palidez, infecciones, petequias y equimosis). La esplenomegalia y las adenopatías son frecuentes en la LLA, pero raras en la LMA (solo 10% tiene esplenomegalia o hepatomegalia y las poliadenopatías son raras, por lo que su presencia obliga a sospechar una LLA), pero, la única forma de diferenciarlas con certeza es con el adecuado estudio inmunohistoquímico de las células malignas. La fiebre es un síntoma frecuente en la LMA, pero, algo importante es que siempre se deben descartar infecciones, ya que la LMA se complica con ellas con elevada frecuencia. En este caso, se debe iniciar el estudio con un hemograma y otros exámenes generales y luego se confirma el diagnóstico con una biopsia de médula ósea. - El mieloma también puede tener dolores óseos y síntomas de insuficiencia medular, pero suele afectar a adultos mayores, la esplenomegalia es menos característica y suele tener un curso más lento que la leucemia.

Fuente: Hematología, prueba 1 del 8 de mayo de 2024, P10

34. Un niño de 8 años presenta fiebre y malestar general de dos semanas de evolución. Al examen se aprecia pálido, con algunas equimosis y petequias en las extremidades. Además, se palpa esplenomegalia moderada. El diagnóstico más probable es:

a. Leucemia mieloide crónica
b. Linfoma no Hodgkin
c. Púrpura trombocitopénico trombótico
d. Púrpura trombocitopénico inmune
e. Leucemia linfática aguda

Respuesta correcta: e. Leucemia linfática aguda

Explicación: Si bien las petequias y equimosis son compatibles con una PTI (púrpura trombocitopénica trombótica), la fiebre, palidez y esplenomegalia sugieren una leucemia, la que debe ser aguda, por el tiempo de evolución. La leucemia aguda más frecuente de la infancia es la LLA (leucemia linfática aguda). La PTT (púrpura trombocitopénica trombótica) tiene una presentación caracterizada por insuficiencia renal aguda, con plaquetopenia y anemia hemolítica, más compromiso del sistema nervioso central y periférico (similar al SHU de los niños). El linfoma se presenta con adenopatías y suele no tener petequias ni esplenomegalia. Los síntomas B (fiebre, baja de peso y sudoración nocturna) son clásicos del linfoma de Hodgkin, pero, en realidad se presentan en los demás linfomas, leucemias, infecciones como la tuberculosis y enfermedades inflamatorias como el lupus.

Fuente: Hematología, prueba 4 del 8 de mayo de 2024, P10

35. Un paciente de 40 años consulta por un cuadro de 3 semanas de evolución de malestar general, dolores óseos y aparición de lesiones en la piel. Al examen físico se constatan petequias y equimosis generalizadas, palidez de mucosas y esplenomegalia. El diagnóstico más probable es:

a. Púrpura trombocitopénico inmune
b. Mieloma
c. Púrpura trombocitopénico trombótico
d. Linfoma
e. Leucemia

Respuesta correcta: e. Leucemia

Explicación: Es una leucemia aguda (LLA: leucemia linfática aguda o LMA: leucemia mieloide aguda): dolores óseos, síntomas de insuficiencia medular (astenia, palidez, infecciones, petequias y equimosis). La esplenomegalia y las adenopatías son frecuentes en la LLA, pero raras en la LMA (solo 10% tiene esplenomegalia o hepatomegalia y las poliadenopatías son raras, por lo que su presencia obliga a sospechar una LLA), pero, la única forma de diferenciarlas con certeza es con el adecuado estudio inmunohistoquímico de las células malignas. La fiebre es un síntoma frecuente en la LMA, pero, algo importante es que siempre se deben descartar infecciones, ya que la LMA se complica con ellas con elevada frecuencia. En este caso, se debe iniciar el estudio con un hemograma y otros exámenes generales y luego se confirma el diagnóstico con una biopsia de médula ósea. - El mieloma también puede tener dolores óseos y síntomas de insuficiencia medular, pero suele afectar a adultos mayores, la esplenomegalia es menos característica y suele tener un curso más lento que la leucemia.

Fuente: Hematología, prueba 4 del 8 de mayo de 2024, P12

Leucemias crónicas (8)

36. Una paciente de 69 años, asintomático, se realiza exámenes de control, que muestran un hematocrito: 28%, hemoglobina: 9,5 g/dl, plaquetas: 80.000 por mm3, glóbulos blancos: 26.800 por mm3, linfocitos: 85%, monocitos: 2%, neutrófilos: 12%, eosinófilos: 1%. Su examen físico muestra palidez, sin mayores alteraciones. El diagnóstico más probable es:

a. Infección viral
b. Leucemia linfática crónica
c. Mieloma múltiple
d. Leucemia linfática aguda
e. Mielodisplasia

Respuesta correcta: b. Leucemia linfática crónica

Explicación: Es una LLC clásica (adulto mayor, sin síntomas, con leucocitosis de tipo linfocítico, asociado a anemia y trombopenia). Sus linfocitos se describen como de aspecto maduro, con “sombras de Gumprecht” (no confundirlos con los "bastones de Auer de la LMA promielocítica). - La infección viral no tendría anemia ni trombopenia, tendría probablemente menos de 20.000 blancos y alguna clínica de infección viral. - El mieloma múltiple hace pancitopenia en el hemograma, con VHS muy alta. - La LLA es de niños y tendría clínica más agresiva. - La mielodisplasia tiene pancitopenia.

Fuente: Hematología, prueba 1 del 8 de mayo de 2024, P1

37. Un paciente de 70 años se realiza un hemograma, que muestra Hcto: 27%, Hb: 9 g/dl, plaquetas: 80.000 por mm3, blancos: 31.000 por mm3, con 90% linfocitos, 2% monocitos y 8% neutrófilos. El diagnóstico más probable es:

a. Infección viral
b. Leucemia linfática aguda
c. Linfoma
d. Mieloma
e. Leucemia linfática crónica

Respuesta correcta: e. Leucemia linfática crónica

Explicación: Es una LLC clásica: Adulto mayor con linfocitosis mayor a 20.000 por mm3, plaquetopenia y anemia.

Fuente: Hematología, prueba 2 del 8 de mayo de 2024, P1

38. Una mujer de 80 años se realiza un hemograma, que muestra leucocitosis de 40.000 x mm3, con 90% de linfocitos y anemia moderada. Al examen físico no se aprecian alteraciones y en un examen anterior, realizado hace un año, se constata leucocitosis de 30.000 x mm3, también de predominio linfocitario. El diagnóstico más probable es:

a. Reacción leucemoide
b. Linfoma
c. Leucemia linfática crónica
d. Leucocitosis reactiva a infección viral crónica
e. Mielofibrosis

Respuesta correcta: c. Leucemia linfática crónica

Explicación: No tiene clínica viral que lo explique y, además, es improbable que una infección viral dure un año y produzca anemia. Es una LLC clásica: adulto mayor con leucocitosis persistente y pocos o ningún síntoma. El hemograma muestra marcada leucocitosis, con linfocitosis y puede tener anemia y trombocitopenia, habitualmente leve o moderada al momento del diagnóstico. En los estadios tardíos puede tener síntomas B o los síntomas de insuficiencia medular (anemia, trombocitopenia o inmunodepresión). El diagnóstico actualmente se hace con pruebas de inmunohistoquímica, ya sea en sangre periférica, nódulos linfáticos o médula ósea, que muestran el crecimiento monoclonal de linfocitos B disfuncionales. El tratamiento de la LLC suele ser con la sola observación en las etapas iniciales. En los pacientes más avanzados, actualmente se usan múltiples y modernos fármacos y anticuerpos monoclonales específicos contra la LLC.

Fuente: Hematología, prueba 4 del 8 de mayo de 2024, P2

39. Un paciente de 70 años presenta astenia de algunas semanas de evolución, por lo que se solicita un hemograma que muestra hematocrito: 27%, plaquetas: 70.000 por mm3 y glóbulos blancos: 25.000 por mm3, con 95% de linfocitos. No ha presentado otros síntomas y su examen físico no aporta mayor información. El diagnóstico más probable es:

a. Infección viral
b. Infección bacteriana
c. Leucemia aguda
d. Leucemia linfática crónica
e. Linfoma

Respuesta correcta: d. Leucemia linfática crónica

Explicación: Es una LLC clásica: adulto mayor con linfocitosis, más anemia y trombopenia. Suele ser asintomática y diagnosticarse como un hallazgo en el hemograma, o bien tener pocos síntomas de anemia, síntomas B o infecciones (más raro hemorragias o petequias). Su tratamiento suele ser la observación, hasta que está en estadios avanzados en que se usan quimioterapias y anticuerpos monoclonales específicos (acalabrutinib, zanubrutinib, ibrutinib, venetoclax, etc., cuyos nombres no debe saberlos el médico general).

Fuente: Hematología, prueba 3 del 8 de mayo de 2024, P2

40. Una mujer de 80 años se realiza un hemograma, que muestra leucocitosis de 40.000 x mm3, con 90% de linfocitos y anemia moderada. Al examen físico no se aprecian alteraciones y en un examen anterior, realizado hace un año, se constata leucocitosis de 30.000 x mm3, también de predominio linfocitario. El diagnóstico más probable es:

a. Leucocitosis reactiva a infección viral crónica
b. Leucemia linfática crónica
c. Mielofibrosis
d. Reacción leucemoide
e. Linfoma

Respuesta correcta: b. Leucemia linfática crónica

Explicación: No tiene clínica viral que lo explique y, además, es improbable que una infección viral dure un año y produzca anemia. Es una LLC clásica: adulto mayor con leucocitosis persistente y pocos o ningún síntoma. El hemograma muestra marcada leucocitosis, con linfocitosis y puede tener anemia y trombocitopenia, habitualmente leve o moderada al momento del diagnóstico. En los estadios tardíos puede tener síntomas B o los síntomas de insuficiencia medular (anemia, trombocitopenia o inmunodepresión). El diagnóstico actualmente se hace con pruebas de inmunohistoquímica, ya sea en sangre periférica, nódulos linfáticos o médula ósea, que muestran el crecimiento monoclonal de linfocitos B disfuncionales. El tratamiento de la LLC suele ser con la sola observación en las etapas iniciales. En los pacientes más avanzados, actualmente se usan múltiples y modernos fármacos y anticuerpos monoclonales específicos contra la LLC.

Fuente: Hematología, prueba 6 del 5 de mayo de 2024, P6 · Hematología, prueba 3 del 8 de mayo de 2024, P16

41. Un paciente de 70 años presenta astenia de algunas semanas de evolución, por lo que se solicita un hemograma que muestra hematocrito: 27%, plaquetas: 70.000 por mm3 y glóbulos blancos: 25.000 por mm3, con 95% de linfocitos. No ha presentado otros síntomas y su examen físico no aporta mayor información. El diagnóstico más probable es:

a. Leucemia aguda
b. Linfoma
c. Infección viral
d. Leucemia linfática crónica
e. Infección bacteriana

Respuesta correcta: d. Leucemia linfática crónica

Explicación: Es una LLC clásica: adulto mayor con linfocitosis, más anemia y trombopenia. Suele ser asintomática y diagnosticarse como un hallazgo en el hemograma, o bien tener pocos síntomas de anemia, síntomas B o infecciones (más raro hemorragias o petequias). Su tratamiento suele ser la observación, hasta que está en estadios avanzados en que se usan quimioterapias y anticuerpos monoclonales específicos (acalabrutinib, zanubrutinib, ibrutinib, venetoclax, etc., cuyos nombres no debe saberlos el médico general).

Fuente: Hematología, prueba 4 del 8 de mayo de 2024, P8

42. Un paciente de 70 años presenta astenia de algunas semanas de evolución, por lo que se solicita un hemograma que muestra hematocrito: 27%, plaquetas: 70.000 por mm3 y glóbulos blancos: 25.000 por mm3, con 95% de linfocitos. No ha presentado otros síntomas y su examen físico no aporta mayor información. El diagnóstico más probable es:

a. Linfoma
b. Infección bacteriana
c. Infección viral
d. Leucemia aguda
e. Leucemia linfática crónica

Respuesta correcta: e. Leucemia linfática crónica

Explicación: Es una LLC clásica: adulto mayor con linfocitosis, más anemia y trombopenia. Suele ser asintomática o tener pocos síntomas de anemia o síntomas B.

Fuente: Hematología, prueba 4 del 8 de mayo de 2024, P9

43. ¿Cuál de los siguientes hemogramas le parece más sugerente de una leucemia linfoide crónica?

a. Hematocrito: 45%, hemoglobina: 15 g/dl, plaquetas: 250.000 x mm3, blancos: 7.500 x mm3, linfocitos: 50%, Monocitos: 4%, segmentados: 40%, baciliformes: 3%, mielocitos: 0%, promielocitos: 0%, blastos: 0%, eosinófilos: 2%, basófilos: 1%
b. Hematocrito: 25%, hemoglobina: 8 g/dl, plaquetas: 50.000 x mm3, blancos: 27.500 x mm3, linfocitos: 88%, Monocitos: 0%, segmentados: 12%, baciliformes: 0%, mielocitos: 0%, promielocitos: 0%, blastos: 0%, eosinófilos: 0%, basófilos: 0%
c. Hematocrito: 45%, hemoglobina: 15 g/dl, plaquetas: 250.000 x mm3, blancos: 17.500 x mm3, linfocitos: 13%, Monocitos: 5%, segmentados: 65%, baciliformes: 15%, mielocitos: 0%, promielocitos: 0%, blastos: 0%, eosinófilos: 1%, basófilos: 1%
d. Hematocrito: 45%, hemoglobina: 15 g/dl, plaquetas: 500.000 x mm3, blancos: 32.500 x mm3, linfocitos: 10%, Monocitos: 5%, segmentados: 31%, baciliformes: 21%, mielocitos: 10%, promielocitos: 5%, blastos: 2%, eosinófilos: 6%, basófilos: 4%
e. Hematocrito: 45%, hemoglobina: 15 g/dl, plaquetas: 350.000 x mm3, blancos: 18.500 x mm3, linfocitos: 80%, Monocitos: 7%, segmentados: 12%, baciliformes: 1%, mielocitos: 0%, promielocitos: 0%, blastos: 0%, eosinófilos: 0%, basófilos: 0%

Respuesta correcta: b. Hematocrito: 25%, hemoglobina: 8 g/dl, plaquetas: 50.000 x mm3, blancos: 27.500 x mm3, linfocitos: 88%, Monocitos: 0%, segmentados: 12%, baciliformes: 0%, mielocitos: 0%, promielocitos: 0%, blastos: 0%, eosinófilos: 0%, basófilos: 0%

Explicación: Opción A = hemograma normal Opción B = Leucemia linfática crónica Opción C = Infección bacteriana Opción D = Leucemia mieloide crónica Opción E = Infección viral

Fuente: Hematología, prueba 8 del 8 de mayo de 2024, P9

Síndromes mieloproliferativos (14)

44. Un paciente de 50 años, sin antecedentes de importancia, presenta una TVP de extremidad inferior izquierda. Además de los signos de TVP, al examen físico se aprecia piel violácea. En sus exámenes destaca hemograma con hematocrito: 63%, Hb: 21 g/dl, plaquetas: 460.000 x mm3 y blancos: 9.000 x mm3, con fórmula diferencial normal. No fuma, no tiene enfermedades pulmonares y no ha vivido en altura. ¿Qué alteración es más probable de encontrar en este paciente?

a. Positividad de la prueba de Coombs indirecto
b. Cromosoma Filadelfia
c. Poliadenopatías
d. Esplenomegalia
e. Positividad de la prueba de Coombs directo

Respuesta correcta: d. Esplenomegalia

Explicación: Es una policitemia vera clásica. Se caracteriza por elevación del hematocrito, sin causa aparente y suele asociarse a trombocitosis (como en este caso) y a esplenomegalia. Se complica con trombosis.

Fuente: Hematología, prueba 4 del 8 de mayo de 2024, P1

45. Un paciente de 55 años presenta una celulitis en el pie izquierdo, la que se trata con cloxacilina y antiinflamatorios. Se solicita un hemograma que demuestra hematocrito: 40%, leucocitosis de 65.000 por mm3, con desviación izquierda y plaquetas de 895.000 por mm3. Luego de 10 días de tratamiento antibiótico, la lesión cutánea ha disminuido considerablemente, pero el hemograma permanece con valores muy similares. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?:

a. Leucemia aguda
b. Reacción leucemoide
c. Leucemia mieloide crónica
d. Trombocitosis esencial
e. Reacción a fármacos

Respuesta correcta: c. Leucemia mieloide crónica

Explicación: Tiene el hemograma clásico de la LMC. Si bien, al inicio, pudo haber sido una reacción leucemoide, con trombocitosis reactiva (aunque igual la principal sospecha sería una LMC). Ya transcurrido el tiempo, con mejoría clínica, era de esperar que tendiera a normalizar el hemograma. Al no hacerlo, el diagnóstico es una LMC con alta probabilidad.

Fuente: Hematología, prueba 5 del 8 de mayo de 2024, P1

46. Un paciente de 70 años presenta astenia de algunas semanas de evolución, asociada a fiebre, por lo que se solicita un hemograma que muestra hematocrito: 27%, plaquetas: 70.000 por mm3 y glóbulos blancos: 45.000 por mm3, con 16% de segmentados, 0% de baciliformes, 0% de mielocitos, 40% de promielocitos, 37% de blastos, 0% eosinófilos, 0% de basófilos y 7% linfocitos. No ha presentado otros síntomas y su examen físico no aporta mayor información. El diagnóstico más probable es:

a. Infección viral
b. Infección bacteriana
c. Leucemia aguda
d. Leucemia mieloide crónica

e. Linfoma

Respuesta correcta: d. Leucemia mieloide crónica

Explicación: Es una LMC clásica: marcada leucocitosis, con gran desviación izquierda, sin hiato leucémico. Habitualmente sin anemia, ni trombopenia, sino trombocitosis. Además, puede elevar los basófilos, eosinófilos y monocitos. La infección bacteriana rara vez eleva los blancos a más de 20.000. Sin embargo, existe la reacción leucemoide, secundaria a una infección bacteriana, que puede ser indistinguible de una LMC, pero con la diferencia que existe una causa infecciosa evidente de base (ej. una neumonía o meningitis o bacteremia) y que tiende a normalizarse después de pasado el cuadro infeccioso. El diagnóstico de certeza se logra con la biopsia de médula ósea y la identificación del cromosoma Filadelfia (translocación 9:22). Debido a que dicho cromosoma codifica para una proteína específica, un tipo de tirosinquinasa, que es la causante de la proliferación celular y que es posible atacarla directamente con fármacos específicos, por lo que actualmente el tratamiento de elección son dichos fármacos. El clásico es el mesilato de imatinib (hay que saberlo y no es un anticuerpo monoclonal, sino un medicamento común), pero actualmente existen fármacos de segunda generación que son más seguros y eficaces: dasatinib, nilotinib, ponatinib y asciminib (no hay que saber los nombres de memoria, pero sí saber que existen). La hidroxiúrea ha quedado obsoleta, por lo que rara vez se usa. El trasplante de médula ósea, aunque curativo, es caro y riesgoso, por lo que actualmente solo se utiliza cuanto están contraindicados todos los inhibidores de la tirosinquinasa.

Fuente: Hematología, prueba 3 del 8 de mayo de 2024, P2 · Hematología, prueba 6 del 5 de mayo de 2024, P12

47. Un paciente de 55 años consulta por epistaxis. Se realiza un hemograma con hematocrito: 50%, plaquetas: 800.000 por mm3 y blancos: 9.400 por mm3, con fórmula diferencial normal. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

a. Trombocitosis reactiva
b. Mielodisplasia
c. Púrpura trombocitopénico trombótico
d. Trombocitosis esencial
e. Macroglobulinemia de Waldestrom

Respuesta correcta: d. Trombocitosis esencial

Explicación: Tiene una trombocitosis mayor a 600.000 por mm3, sin otras alteraciones, por lo que lo más probable es que sea una trombocitosis esencial (TE). La epistaxis se explica porque las plaquetas pueden ser disfuncionales (la TE se presenta tanto hemorragias, como trombosis). La confirmación de la TE requiere de biopsia de médula ósea (aumento monoclonal de megacariocitos) y estudio inmunohistoquímico (excluir otros síndromes mieloproliferativos y confirmar la presencia del gen JAK2 u otro marcador. La forma más habitual de presentarse es como un hallazgo en el hemograma. Otros casos se presenta con síntomas inespecíficos (ej. mareos) o con hemorragias o trombosis. - La trombocitosis reactiva, estaría asociada a una infección, otra causa de respuesta inflamatoria sistémica o ferropenia y es raro que la trombocitosis sea tan elevada. Además, suele ser transitoria y mejora, al desaparecer la causa. - La mielodisplasia se presenta como una pancitopenia. - La PTT tiene trombopenia y anemia hemolítica. - La MGW hace trombosis y es una gamapatía monoclonal.

Fuente: Hematología, prueba 6 del 5 de mayo de 2024, P3

48. ¿Cuál de los siguientes hemogramas es más sugerente de una trombocitosis esencial?

a. Hematocrito: 45%, blancos: 32.000, linfocitos: 17%, segmentados: 50%, baciliformes: 20%, mielocitos: 10%, plaquetas: 500.000.

b. Hematocrito: 40%, blancos: 8.000, linfocitos: 35%, segmentados: 60%, baciliformes: 2%, mielocitos: 0%, plaquetas: 700.000.

c. Hematocrito: 25%, blancos: 22.000, linfocitos: 8%, segmentados: 0%, baciliformes: 0%, mielocitos: 90%, plaquetas: 40.000.

d. Hematocrito: 45%, blancos: 12.000, segmentados: 70%, baciliformes: 10%, mielocitos: 1%, plaquetas: 490.000.

e. Hematocrito: 45%, blancos: 8.200, segmentados: 60%, baciliformes: 0%, mielocitos: 0%, plaquetas: 50.000.

Respuesta correcta: b. Hematocrito: 40%, blancos: 8.000, linfocitos: 35%, segmentados: 60%, baciliformes: 2%, mielocitos: 0%, plaquetas: 700.000.

Explicación: Opción A = Leucemia mieloide crónica (marcada leucocitosis con desviación izquierda y trombocitosis). Opción B = Trombocitosis esencial (trombocitosis aislada mayor a 600.000). Opción C = Leucemia mieloide aguda, de tipo mielocítica (aunque el hemograma suele ser distinto, en la realidad) Opción D = Infección bacteriana (leucocitosis, desviación izquierda) con trombocitosis reactiva. Opción E = Trombopenia aislada. Probablemente es una PTI.

Fuente: Hematología, prueba 1 del 8 de mayo de 2024, P4

49. ¿Cuál de las siguientes opciones es MENOS probable de ser encontrada en un paciente con leucemia mieloide crónica?

a. Síntomas B

b. Presencia de translocación 9:22 (cromosoma Filadelfia)

c. Leucocitosis con desviación izquierda

d. Trombocitopenia

e. Esplenomegalia

Respuesta correcta: d. Trombocitopenia

Explicación: La leucemia mieloide crónica (LMC) tiene leucocitosis con desviación izquierda, sin hiato leucémico y con menos de 5% de blastos en sangre periférica (menos de 20 en médula ósea). Se caracteriza por no tener anemia ni trombopenia, sino trombocitosis y puede tener poliglobulia (prolifera todo lo mieloide). Solo en los estadios finales aparecen las citopenias, cuando el paciente comienza con las llamadas "crisis blásticas", que son similares a la LMA. La esplenomegalia es muy frecuente en la LMC.

Fuente: Hematología, prueba 2 del 8 de mayo de 2024, P4

50. Un paciente de 50 años, sin antecedentes de importancia, presenta una TVP de extremidad inferior izquierda. Además de los signos de TVP, al examen físico se aprecia piel violácea. En sus exámenes destaca hemograma con hematocrito: 63%, Hb: 21 g/dl, plaquetas: 460.000 x mm3 y blancos: 9.000 x mm3, con fórmula diferencial normal. No fuma, no tiene enfermedades pulmonares y no ha vivido en altura. ¿Qué alteración es más probable de encontrar en este paciente?

a. Cromosoma Filadelfia

b. Esplenomegalia

c. Poliadenopatías

d. Positividad de la prueba de Coombs directo

e. Positividad de la prueba de Coombs indirecto

Respuesta correcta: b. Esplenomegalia

Explicación: Es una policitemia vera clásica. Se caracteriza por elevación del hematocrito, sin causa aparente y suele asociarse a trombocitosis (como en este caso) y a esplenomegalia. Se complica con trombosis. El cromosoma Filadelfia (translocación 9:22) se asocia a leucemia mieloide crónica (LMC) y, en menor medida, en niños se asocia a leucemias linfoblásticas agudas (LLA).

Fuente: Hematología, prueba 6 del 5 de mayo de 2024, P5

51. Un paciente de 50 años consulta por dolor abdominal. Al examen físico se palpa una marcada esplenomegalia sensible, por lo que se solicita un hemograma que muestra hematocrito: 30%, plaquetas: 70.000 x mm3, blancos: 3.000 por mm3, frotis con presencia de dacriocitos. El diagnóstico más probable es:

a. Mielodisplasia
b. Mieloma múltiple
c. Leucemia
d. Aplasia medular
e. Mielofibrosis

Respuesta correcta: e. Mielofibrosis

Explicación: Es una mielofibrosis (también llamada metaplasia mieloide) clásica: pancitopenia con marcada esplenomegalia (es la enfermedad con mayor esplenomegalia) y dacriocitos (glóbulos rojos en forma de lágrima, que se producen al deformarse los GR dentro de la médula, a causa de las fibras que la invaden). Se diagnostica con biopsia de médula ósea, que muestra la fibrosis de la médula. Si bien los dacriocitos se describen con frecuencia en la mielofibrosis, también pueden verse en otras patologías. Por cultura general, se muestra una imagen de dacriocitos (fuente: https://www.facebook.com/bioquimicosdiagnosticos): No hay ninguna descripción de la foto disponible.

Fuente: Hematología, prueba 2 del 8 de mayo de 2024, P6

52. ¿Cuál de las siguientes opciones orienta al diagnóstico de policitemia vera, en un paciente con poliglobulia?

a. Disminución de los reticulocitos
b. Disminución de la presión parcial de oxígeno
c. Elevación de la eritropoyetina
d. Trombocitopenia
e. Esplenomegalia

Respuesta correcta: e. Esplenomegalia

Explicación: La policitemia vera (PV) es un síndrome mieloproliferativo (SMP), que se caracteriza por elevación de los glóbulos rojos. Generalmente aumenta la cantidad de reticulocitos, pero mantienen una proporción normal. La PaO2 suele estar normal (si está baja, será la hipoxia la causa de la poliglobulia). La EPO (eritropoyetina) está baja o normal (si está alta, será la elevación de EPO la causa de la poliglobulia, la que sería secundaria a la patología que eleva la EPO, por ejemplo, el EPOC). Generalmente se asocia a trombocitosis (ya que los SMP suelen mezclarse entre ellos y uno de ellos es la trombocitosis esencial). La esplenomegalia es característica.

Fuente: Hematología, prueba 8 del 8 de mayo de 2024, P8

53. ¿Cuál de los siguientes hemogramas le parece más sugerente de una leucemia mieloide crónica?

a. Hematocrito: 45%, hemoglobina: 15 g/dl, plaquetas: 250.000 x mm3, blancos: 7.500 x mm3, linfocitos: 30%, Monocitos: 4%, segmentados: 60%, baciliformes: 3%, mielocitos: 0%, promielocitos: 0%, blastos: 0%, eosinófilos: 2%, basófilos: 1%

b. Hematocrito: 25%, hemoglobina: 8 g/dl, plaquetas: 50.000 x mm3, blancos: 47.500 x mm3, linfocitos: 10%, Monocitos: 0%, segmentados: 20%, baciliformes: 0%, mielocitos: 0%, promielocitos: 0%, blastos: 70%, eosinófilos: 0%, basófilos: 0%

c. Hematocrito: 45%, hemoglobina: 15 g/dl, plaquetas: 250.000 x mm3, blancos: 17.500 x mm3, linfocitos: 13%, Monocitos: 5%, segmentados: 65%, baciliformes: 15%, mielocitos: 0%, promielocitos: 0%, blastos: 0%, eosinófilos: 1%, basófilos: 1%

d. Hematocrito: 45%, hemoglobina: 15 g/dl, plaquetas: 500.000 x mm3, blancos: 32.500 x mm3, linfocitos: 10%, Monocitos: 5%, segmentados: 31%, baciliformes: 21%, mielocitos: 10%, promielocitos: 5%, blastos: 2%, eosinófilos: 6%, basófilos: 4%

e. Hematocrito: 25%, hemoglobina: 8 g/dl, plaquetas: 50.000 x mm3, blancos: 38.500 x mm3, linfocitos: 10%, Monocitos: 0%, segmentados: 40%, baciliformes: 0%, mielocitos: 0%, promielocitos: 50%, blastos: 0%, eosinófilos: 0%, basófilos: 0%

Respuesta correcta: d. Hematocrito: 45%, hemoglobina: 15 g/dl, plaquetas: 500.000 x mm3, blancos: 32.500 x mm3, linfocitos: 10%, Monocitos: 5%, segmentados: 31%, baciliformes: 21%, mielocitos: 10%, promielocitos: 5%, blastos: 2%, eosinófilos: 6%, basófilos: 4%

Explicación: - Opción A = hemograma normal. - Opción B = Leucemia mieloide aguda, de tipo mieloblástico (leucocitosis con muchos blastos y bicitopenia: anemia y trombopenia). - Opción C = Infección bacteriana (leucocitosis de predominio neutrofílico y desviación izquierda). - Opción D = LMC (marcada leucocitosis de predominio neutrofílico, con gran desviación izquierda y elevación de todo lo mieloide, ejemplo: plaquetas, eosinófilos, basófilos). - Opción E = Leucemia mieloide aguda, de tipo promielocítica (leucocitosis, con hiato leucémico y muchos promielocitos, más bicitopenia; aunque el hemograma suele ser algo distinto al ahí mostrado).

Fuente: Hematología, prueba 2 del 8 de mayo de 2024, P10

54. ¿Cuál de las siguientes opciones orienta al diagnóstico de policitemia vera, en un paciente con poliglobulia?

a. Disminución de la presión parcial de oxígeno

b. Disminución de los reticulocitos

c. Trombocitopenia

d. Esplenomegalia

e. Elevación de la eritropoyetina

Respuesta correcta: d. Esplenomegalia

Explicación: La policitemia vera (PV) es un síndrome mieloproliferativo (SMP), que se caracteriza por elevación de los glóbulos rojos. Generalmente aumenta la cantidad de reticulocitos, pero mantienen una proporción normal. La PaO2 suele estar normal (si está baja, será la hipoxia la causa de la poliglobulia). La EPO está baja o normal (si está alta, será la elevación de EPO la causa de la poliglobulia). Generalmente se asocia a trombocitosis (ya que los SMP suelen mezclarse entre ellos y uno de ellos es la trombocitosis esencial). La esplenomegalia es característica.

Fuente: Hematología, prueba 4 del 8 de mayo de 2024, P11

55. En una poliglobulia, todos los datos siguientes concuerdan con una policitemia vera, EXCEPTO uno. Señálelo:

a. Aumento de la masa de hematíes.
b. Esplenomegalia.
c. Leucocitosis y trombocitosis.
d. Eritropoyetina sérica alta.
e. Saturación arterial de oxígeno normal.

Respuesta correcta: d. Eritropoyetina sérica alta.

Explicación: Si la eritropoyetina (EPO) está elevada, se presume que la causa de la poliglobulia es secundaria a hipoxia o a otra causa de elevación de la EPO. En cambio, la policitemia vera tiene EPO disminuida o dentro del rango normal. De todos modos, actualmente, lo más importante es ir a buscar la presencia del gen JAK2 o de alguna otra alteración genética asociada a la policitemia vera.

Fuente: Hematología, prueba 7 del 8 de mayo de 2024, P12

56. Un paciente de 50 años, sin antecedentes de importancia, presenta una TVP de extremidad inferior izquierda. Además de los signos de TVP, al examen físico se aprecia piel violácea. En sus exámenes destaca hemograma con hematocrito: 63%, Hb: 21 g/dl, plaquetas: 460.000 x mm3 y blancos: 9.000 x mm3, con fórmula diferencial normal. El diagnóstico más probable es:

a. Déficit de antitrombina III
b. Leucemia mieloide crónica
c. Leucemia mieloide aguda promielocítica (M3)
d. Macrobulinemia de Waldeström
e. Policitemia vera

Respuesta correcta: e. Policitemia vera

Explicación: De todas las opciones, la policitema vera (PV) es la única alternativa que tiene policitemia o poliglobulia (hematocrito mayor a 55% o hemoglobina mayor a 18 g/dl). Además, se caracteriza por tener elevación de las plaquetas e incluso puede tener leucocitosis (recordar que los síndrome mieloproliferativos tienen a "mezclarse" entre ellos). Suele hacer un síndrome de hiperviscosidad, lo que produce trombosis venosas y arteriales. La fascies pletórica (cara enrojecida) puede estar presente, pero es más inespecífica. Astenia, mareos y síntomas visuales también suelen describirse en la PV. - Finalmente, el déficit de AT-III, la leucemia promielocítica y la macroglobulinemia de Waldeström pueden producir trombosis. De hecho, de las leucemias, la promielocítica es la más “trombofílica”.

Fuente: Hematología, prueba 3 del 8 de mayo de 2024, P14

57. Un paciente de 50 años consulta por dolor abdominal. Al examen físico se palpa una marcada esplenomegalia sensible, por lo que se solicita un hemograma que muestra hematocrito: 30%, plaquetas: 70.000 x mm3, blancos: 3.000 por mm3, frotis con presencia de dacriocitos. El diagnóstico más probable es:

a. Mielofibrosis
b. Aplasia medular
c. Leucemia
d. Mieloma múltiple
e. Mielodisplasia

Respuesta correcta: a. Mielofibrosis

Explicación: Es una mielofibrosis clásica: pancitopenia con marcada esplenomegalia (es la enfermedad con mayor esplenomegalia) y dacriocitos (glóbulos rojos en forma de lágrima, que se producen al deformarse los GR dentro de la médula, a causa de las fibras que la invaden).

Fuente: Hematología, prueba 4 del 8 de mayo de 2024, P14

Linfomas y síndrome adenopático (9)

58. Un paciente de 30 años presenta un cuadro de un mes de evolución de malestar general, fiebre intermitente y baja de peso de 3 kilogramos. Al examen físico se palpan varias adenopatías cervicales y axilares bilaterales, mayor a derecha, indoloras, de hasta 4 cm de diámetro. El diagnóstico más probable es:

a. Linfoma
b. Leucemia linfática crónica
c. Infección viral
d. Mieloma múltiple
e. Leucemia linfática aguda

Respuesta correcta: a. Linfoma

Explicación: Tiene síntomas B (fiebre, baja de peso y falta la sudoración nocturna) más adenopatías. Por tanto, es un linfoma clásico.

Fuente: Hematología, prueba 1 del 8 de mayo de 2024, P2

59. Una paciente de 34 años, presenta compromiso del estado general y fiebre intermitente desde hace 3 semanas. Al examen físico se aprecian múltiples adenopatías cervicales bilaterales, y algunas axilares de entre 2 y 4 cm de diámetro, indoloras. Su examen abdominal y cardiopulmonar es normal. Su hemograma demuestra hematocrito: 38%, hemoglobina: 13 g/dl, VCM: 91 ft, blancos: 9.900 x mm3, con 50% de linfocitos, 40% de neutrófilos y plaquetas: 189.000 x mm3. Los ANA, factor reumatoide y ANCA están negativos. El diagnóstico más probable es:

a. Leucemia linfática crónica
b. Linfoma
c. Mononucleosis infecciosa
d. Leucemia aguda
e. Lupus

Respuesta correcta: b. Linfoma

Explicación: Es un linfoma clásico, con la fiebre como síntomas B y la presencia de adenopatías. Si bien la mononucleosis puede producir una clínica similar, le falta la odinofagia, como síntoma importante y, además, en la mononucleosis la fiebre suele durar una o dos semanas, aunque hay algunos casos en que dura más (la astenia, puede durar un mes). En este caso, el hemograma está normal, lo que hace improbable las leucemias, la mononucleosis (que suele tener linfocitosis atípica) y el lupus (que suele tener trombocitopenia, leucopenia, linfopenia o anemia, ya sea hemolítica o por enfermedades crónicas).

Fuente: Hematología, prueba 5 del 8 de mayo de 2024, P4

60. Un niño de 6 años presenta un cuadro de fiebre, baja de peso y sudoración nocturna, asociada a malestar general. Al examen físico se aprecia pálido y se palpa esplenomegalia, de 5 cm bajo el reborde costal. La conducta más adecuada es:

a. Realizar biopsia esplénica

b. Iniciar corticoides orales
c. Solicitar hemograma
d. Solicitar biopsia ganglionar
e. Solicitar hibridación in situ, en busca del Cromosoma Filadelfia.

Respuesta correcta: c. Solicitar hemograma

Explicación: La sospecha es una leucemia aguda (síntomas B, esplenomegalia y signos de insuficiencia medular: en este caso la palidez sugiere anemia). Así que el primer examen debe ser el hemograma y luego la biopsia de médula ósea. La hibridación in situ, eventualmente se pedirá más adelante, para tipificar la leucemia, pero ese manejo escapa a lo exigido para el médico general (aunque sí se debe saber que la hibridación in situ es el examen que identifica las translocaciones, como el cromosoma Filadelfia de la LMC).

Fuente: Hematología, prueba 3 del 8 de mayo de 2024, P7

61. Un paciente de 40 años presenta aumento de volumen en el cuello. Al examen físico se aprecian 3 adenopatías de entre 2 y 4 cm en el triángulo anterior derecho del cuello. Se inicia amoxicilina más ácido clavulánico y antiinflamatorios, controlándose 2 semanas después, sin presentar mejoría. El paciente presenta además un hemograma y una radiografía de tórax, ambos normales. La conducta más adecuada es:

a. Observar evolución
b. Iniciar tratamiento con azitromicina
c. Solicitar electroforesis de proteínas
d. Solicitar biopsia de médula ósea
e. Solicitar biopsia ganglionar

Respuesta correcta: e. Solicitar biopsia ganglionar

Explicación: La sospecha diagnóstica es un linfoma, en que se diagnostica con biopsia ganglionar (es una biopsia excisional), a pesar de que antes se estudia con exámenes generales (hemograma, radiografía de tórax, etc). De hecho, toda adenopatía persistente (mayor a 2 semanas, a pesar de indicar AINEs y antibióticos) debe ser biopsiada. También se biopsian las que persisten por más de 3 a 4 semanas, sin tener una causa que las explique, aun cuando no haya recibido antibióticos.

Fuente: Hematología, prueba 3 del 8 de mayo de 2024, P8

62. ¿Cuál de las siguientes alteraciones es más frecuente en los pacientes diagnosticados de linfoma?

a. Adenopatías
b. Anemia
c. Elevación de las proteínas plasmáticas
d. Dolores óseos
e. Esplenomegalia

Respuesta correcta: a. Adenopatías

Explicación: Los linfomas se caracterizan por poliadenopatías persistentes. Además, pueden tener síntomas B (baja de peso, fiebre y sudoración nocturna), aunque son síntomas inespecíficos y que no siempre están presentes. Salvo en las etapas más avanzadas, suelen cursar sin anemia; de hecho, su hemograma suele ser normal. La elevación de proteínas es característica de las mielopatías, como el mieloma (paraproteinemia monoclonal). Los dolores óseos son clásicos del mieloma, pero también se ven

en las leucemias agudas. La esplenomegalia se ve en las leucemias mieloides, en los síndromes mieloproliferativos y en las mielodisplasias.

Fuente: Hematología, prueba 7 del 8 de mayo de 2024, P8

63. Un paciente de 30 años presenta un cuadro de un mes de evolución de malestar general, fiebre intermitente y baja de peso de 3 kilogramos. Al examen físico se palpan varias adenopatías cervicales y axilares bilaterales, mayor a derecha, indoloras, de hasta 4 cm de diámetro. El diagnóstico más probable es:

a. Leucemia linfática crónica
b. Linfoma
c. Infección viral
d. Leucemia linfática aguda
e. Mieloma múltiple

Respuesta correcta: b. Linfoma

Explicación: Tiene síntomas B (fiebre, baja de peso y falta la sudoración nocturna) más adenopatías. Por tanto, es un linfoma clásico.

Fuente: Hematología, prueba 4 del 8 de mayo de 2024, P13

64. Un adolescente de 15 años consulta por fiebre y odinofagia, de 8 días de evolución. Al examen físico se aprecia con ictericia leve, T°: 38,5°C y se palpan múltiples adenopatías cervicales sensibles. La faringe está eritematosa, con aumento de volumen amigdalino y escaso exudado blanquecino. Además, es posible palpar el bazo. El diagnóstico más probable es:

a. Leucemia aguda
b. Linfoma
c. Mononucleosis infecciosa
d. Anemia hemolítica autoinmune
e. Leucemia linfática crónica

Respuesta correcta: c. Mononucleosis infecciosa

Explicación: Es una mononucleosis infecciosa clásica, con la triada de odinofagia, adenopatías y fiebre, más otros elementos sugerentes: la ictericia (hepatitis), exudado amigdalino y esplenomegalia. La leucemia tendría anemia, trombopenia y no tendría la odinofagia, el exudado, ni la ictericia (aunque en realidad la leucemia sí puede tenerlos, pero sugieren mucho más una mononucleosis). El hemograma de la mononucleosis suele mostrar leucocitosis con linfocitosis y linfocitos atípicos. Se diagnostica actualmente con serología para virus de Epstein Barr (se pide como IgM-VEB o IgM-VCA [viral capsid antigen]). Se maneja con tratamiento sintomático. El linfoma sí tiene adenopatías, pero nada de lo demás (ej. Es raro que tenga odinofagia).

Fuente: Hematología, prueba 7 del 8 de mayo de 2024, P13

65. Un niño de 6 años presenta un cuadro de fiebre, baja de peso y sudoración nocturna, asociada a malestar general. Al examen físico, se palpa varias adenopatías inguinales y axilares indoloras. Su hemograma demuestra anemia normocítica leve, sin otras alteraciones. La conducta más adecuada es:

a. Realizar biopsia esplénica
b. Iniciar corticoides orales
c. Solicitar biopsia de médula ósea

d. Solicitar biopsia ganglionar
e. Solicitar hibridación in situ, en busca del Cromosoma Filadelfia.

Respuesta correcta: d. Solicitar biopsia ganglionar

Explicación: La sospecha es un linfoma, ya que tiene los síntomas B (baja de peso, fiebre y sudoración) más las poliadenopatías características. El hemograma, no muestra nada más allá de una leve anemia, por lo que no parece ser leucemia. Lo más correcto es solicitar exámenes generales, como radiografía de tórax y luego proceder a la biopsia ganglionar, para confirmar el diagnóstico. El Cr. Filadelfia es de la LMC y algunas LLA. La biopsia debe realizarse antes de indicar corticoides. Cuando no hay sospecha de linfoma, sino solo una adenopatía periférica, se suelen observar por 3 a 4 semanas o tratar con antibióticos por 2 semanas, biopsiándolas solo si persisten. La biopsia de las adenopatías se prefiere que sea excisional (en las que son muy grandes, se hace excisional), ya que las por aguja fina tienen mal redimiento.

Fuente: Hematología, prueba 6 del 5 de mayo de 2024, P17

66. Mujer de 24 años consulta por fiebre, baja de peso y sudoración nocturna. Al examen presenta poliadenopatías cervicales. El hemograma es normal. La radiografía de tórax muestra mediastino ensanchado. El diagnóstico más probable es:

a. Infección por Bartonella henselae
b. Tuberculosis
c. Linfoma
d. Leucemia
e. Timoma

Respuesta correcta: c. Linfoma

Explicación: Es un linfoma clásico: adenopatías más síntomas B (fiebre, baja de peso y sudoración nocturna). El mediastino ancho se debe a las adenopatías mediastínicas. Es importante recalcar que la tuberculosis podría presentarse igual, pero además tendría clínica respiratoria (ej. tos, expectoración, hemoptisis) y la radiografía de tórax mostraría afectación pulmonar (ej. retracción y fibrosis mayor en los ápices).

Fuente: Hematología, prueba 7 del 8 de mayo de 2024, P17

Mieloma múltiple y gammapatías (6)

67. Un paciente de 80 años consulta por dolores óseos y astenia. Al examen físico está pálido, sin otras alteraciones. En sus exámenes generales destaca un hemograma con anemia y plaquetopenia, una creatinina de 2,4 mg/dl y un calcio de 13,6 mg/dl. La conducta más adecuada es:

a. Solicitar radiografía de cráneo, electroforesis de proteínas y biopsia de médula ósea
b. Solicitar radiografía de tórax y biopsia de ganglio linfático
c. Iniciar prednisona oral y controlar ambulatoriamente
d. Realizar esplenectomía y solicitar hemograma de control
e. Observar evolución

Respuesta correcta: a. Solicitar radiografía de cráneo, electroforesis de proteínas y biopsia de médula ósea

Explicación: La sospecha es un mieloma múltiple (MM), que se suele presenta como un adulto mayor con anemia, hipercalcemia e insuficiencia renal por depósito de cadenas livianas de inmunoglobulina. Se diagnostica con la biopsia de médula ósea (muestra más de 10% de plasmocitos). Sin embargo, además se

suele estudiar con radiografías de cráneo y la electroforesis de proteínas, tanto en sangre como en orina, más un sinnúmero de exámenes generales (albúmina, proteínas totales, inmunoglobulinas, electrolitos, función renal, hepática, etc.). Vale la pena mencionar que las MGUS (gamapatía monoclonal de significado incierto) puede tener una biopsia similar, ya que la diferencia con el mieloma la da precisamente la afección de los demás órganos o sistemas (el MGUS no las afecta, mientras que el MM sí).

Fuente: Hematología, prueba 8 del 8 de mayo de 2024, P2

68. Un paciente de 70 años presenta un cuadro de astenia y dolores óseos. Se solicitan exámenes generales en los que se aprecia creatinina: 2,4 mg/dl, Hcto: 29%, plaquetas: 100.000 por mm3 y blancos: 3.900 por mm3. El diagnóstico más probable es:

a. Leucemia
b. Mielodisplasia
c. Mielofibrosis
d. Mieloma múltiple
e. Macroglobulinemia de Waldeström

Respuesta correcta: d. Mieloma múltiple

Explicación: Los dolores óseos son característicos del mieloma múltiple, pero también se ven en las leucemias agudas. El hemograma muestra una pancitopenia, lo que orienta mucho más a mieloma que a leucemia (la inmensa mayoría de las leucemias vienen con leucocitosis y solo un 10% de las leucemias agudas hacen leucopenia). Además, la insuficiencia renal orienta más a mieloma. La mielodisplasia sí tendría pancitopenia, pero son más raros los dolores óseos y la elevación de la creatinina.

Fuente: Hematología, prueba 2 del 8 de mayo de 2024, P3

69. Paciente de 65 años presenta en su analítica creatinina de 2,1, anemia con Hb:9,7 e hipercalcemia de 11,1. El diagnóstico de sospecha es:

a. Cáncer de próstata
b. Mieloma múltiple
c. Insuficiencia renal crónica, con hiperparatiroidismo asociado
d. Déficit de proteína C
e. Anemia de enfermedades crónicas

Respuesta correcta: b. Mieloma múltiple

Explicación: El mieloma múltiple se caracteriza por anemia, hipercalcemia e insuficiencia renal. La PTH, está disminuida en la hipercalcemia de causa oncológica. En cambio, la IRC con hiperparatiroidismo secundario tiene también anemia, pero hipocalcemia, con PTH elevada. El cáncer de próstata sí podría manifestarse de esta forma, pero le falta la clínica de uropatía obstructiva o alguna otra cosa que oriente a dicho diagnóstico.

Fuente: Hematología, prueba 4 del 8 de mayo de 2024, P5

70. Un paciente de 65 años, consulta por malestar general, dolores óseos y anemia. Al examen físico se constata palidez, y algunas petequias en las extremidades inferiores. Se solicita un hemograma, que muestra Hematocrito: 25%, plaquetas: 20.000 por mm3 y blancos: 2.700 por mm3, VHS: 100 mm/h. Además, se solicita un perfil bioquímico, que destaca por creatinina de 2,5 mg/dl y calcemia de 12,2 mg/dl. El diagnóstico más probable es:

a. Mieloma múltiple
b. Mielofibrosis

c. Leucemia
d. Mielodisplasia
e. Anemia por déficit de vitamina B12

Respuesta correcta: a. Mieloma múltiple

Explicación: Tiene muchos elementos de que orientan a mieloma múltiple: adulto mayor, dolores óseos, pancitopenia, VHS muy alta, insuficiencia renal e hipercalcemia.

Fuente: Hematología, prueba 3 del 8 de mayo de 2024, P6

71. Un paciente de 67 años se realiza un perfil bioquímico que muestra elevación de las proteínas plasmáticas, con albúmina de 3,4 g/dl. Los exámenes generales son normales, al igual que el examen físico. Se solicita una electroforesis de proteínas en plasma, que constata un peak monoclonal de inmunoglobulina G, por lo que se realiza una realiza una biopsia de médula ósea que demuestra elevación del número de plasmocitos, compatible con un MGUS. La conducta más adecuada es:

a. Observar evolución
b. Indicar quimioterapia
c. Iniciar ácido acetil salicílico
d. Iniciar hidroxiurea
e. Realizar trasplante de médula ósea

Respuesta correcta: a. Observar evolución

Explicación: El tratamiento del MGUS (gamapatía monoclonal de significado incierto) es simplemente la observación, ya que en el 98% de los casos no tiene mayores complicaciones. Solo en el 2% restante existe evolución a mieloma múltiple y solo si ello ocurre, se tratará con quimioterapia.

Fuente: Hematología, prueba 7 del 8 de mayo de 2024, P14

72. Paciente de 65 años presenta en su analítica creatinina de 2,1, anemia con Hb:9,7 e hipercalcemia de 11,1. El diagnóstico de sospecha es:

a. Insuficiencia renal crónica, con hiperparatiroidismo asociado
b. Anemia de enfermedades crónicas
c. Mieloma múltiple
d. Déficit de proteína C
e. Cáncer de próstata

Respuesta correcta: c. Mieloma múltiple

Explicación: El mieloma múltiple se caracteriza por anemia, hipercalcemia e insuficiencia renal. La PTH, está disminuida en la hipercalcemia de causa oncológica. En cambio, la IRC con hiperparatiroidismo secundario tiene también anemia, pero hipocalcemia, con PTH elevada. El cáncer de próstata sí podría manifestarse de esta forma, pero le falta la clínica de uropatía obstructiva o alguna otra cosa que oriente a dicho diagnóstico.

Fuente: Hematología, prueba 7 del 8 de mayo de 2024, P15

Trombocitopenias y púrpuras (11)

73. Un paciente de 63 años, inicia tratamiento con ibuprofeno, debido a una artrosis. Evoluciona con aparición de múltiples petequias en las extremidades inferiores y en el tronco. Se solicita un hemograma

que muestra hematocrito: 45%, hemoglobina: 15 g/dl, plaquetas: 250.000 por mm3, blancos: 7.200 por mm3, con fórmula diferencial normal. El diagnóstico más probable es:

a. Disfunción plaquetaria por ibuprofeno
b. Púrpura trombocitopénico inmune
c. Púrpura trombocitopénico trombótico
d. Hemofilia
e. Enfermedad de Von Willebrand

Respuesta correcta: a. Disfunción plaquetaria por ibuprofeno

Explicación: Tiene clínica de alteración de hemostasia primaria (petequias y hemorragias mucosas). Las plaquetas son las encargadas de la hemostasia primaria, por lo que esto se puede deber a dos grandes causas: 1. Trombopenia y 2. Disfunción plaquetaria. Dado que el hemograma está normal, no puede ser trombopenia, sino que debe ser disfunción plaquetaria. La EvW es congénita, por lo que tendría síntomas desde la infancia y no a los 63 años, por lo que la respuesta es la disfunción por AINEs. El PTI y el PTT tendrían trombopenia. La hemofilia sería congénita y altera la coagulación, es decir, la hemostasia secundaria.

Fuente: Hematología, prueba 3 del 8 de mayo de 2024, P1

74. Un paciente de 63 años, diagnosticado de un púrpura trombocitopénico inmune crónico, en tratamiento con prednisona 40 mg al día, presenta hemorragia digestiva alta, asociada a epistaxis importante. Se inicia reposición de volumen y taponamiento nasal anterior y solicita hemograma, que muestra 3.000 plaquetas por mm3. Además del manejo de su hemorragia digestiva, la conducta más adecuada es:

a. Realizar transfusión de plaquetas
b. Administrar pulsos de metilprednisolona endovenosa
c. Realizar esplenectomía
d. Transfundir plasma fresco congelado
e. Administrar inmunoglobulina G endovenosa más pulsos de metilprednisolona

Respuesta correcta: e. Administrar inmunoglobulina G endovenosa más pulsos de metilprednisolona

Explicación: El tratamiento del PTI con hemorragias graves (independientemente de si es agudo o crónico; si es adulto o niño) es con IgG EV en dosis altas más corticoides endovenosos. Las transfusiones de plaquetas no son muy útiles (ya que tiene anticuerpos que las destruyen), por lo que solo se agregan en casos de urgencia vital o cuando todo lo demás ha fallado. La esplenectomía se indica en el PTI crónico refractario a corticoides orales (que no logra un recuento estable, mayor a 20.000 plaquetas por mm3), como tratamiento a largo plazo. Pero, en este caso, lo urgente es recuperar rápido el número de plaquetas, por lo que se debe administrar la IgG endovenosa (actualmente se recomienda dar también los pulsos de corticoides endovenosas). El rituximab es una alternativa a la esplenectomía, que aunque es menos eficaz, no tiene el riesgo quirúrgico. El rituximab son anticuerpos anti-linfocito B (anti-CD20) y su efecto demora varias semanas en establecerse. El plasma fresco congelado no tiene plaquetas, sino factores de coagulación (se usa en la coagulación intravascular diseminada, en algunos casos).

Fuente: Hematología, prueba 7 del 8 de mayo de 2024, P1

75. Un niño de 6 años presenta aparición de múltiples petequias en el tronco y las extremidades. Además, ha presentado epistaxis en 3 oportunidades, autolimitadas. El examen físico no muestra otras alteraciones y se solicita un hemograma que presenta Hcto: 43%, blancos: 7.600 por mm3 con fórmula diferencial normal y plaquetas: 20.000 por mm3. La conducta más adecuada es:

a. Indicar reposo y observar evolución
b. Solicitar tiempo de protrombina y tiempo de tromboplastina parcial activada
c. Iniciar corticoides orales
d. Derivar para biopsia de médula ósea
e. Realizar transfusión de plaquetas

Respuesta correcta: c. Iniciar corticoides orales

Explicación: El diagnóstico es púrpura trombocitopénica inmune (PTI) aguda (niño con alteración de la hemostasia primaria y trombocitopenia aislada en el hemograma), la que suele tener un curso autolimitado de un par de semanas en el 90% de los casos. Es una pregunta discutible, ya que tanto el reposo, como los corticoides son opciones aceptables. Sin embargo, a pesar de estar en buenas condiciones, por haber tenido epistaxis (síntomas moderados) y por tener menos de 30.000 plaquetas, preferimos la opción de dar corticoides orales. SI hubiese tenido fiebre, esplenomegalia, adenopatías o más alteraciones en el hemograma (ej. anemia o leucopenia), se tendría que hacer una biopsia de médula ósea, para descartar leucemia.

Fuente: Hematología, prueba 2 del 8 de mayo de 2024, P2

76. Un paciente de 35 años presenta un cuadro de fiebre, malestar general y oliguria, de 2 días de evolución, al que luego se agrega sopor y una convulsión tónico clónica en una oportunidad. Al examen físico está hipertenso, soporoso, con edema de extremidades inferiores y se aprecian petequias en las piernas y abdomen. Se solicitan exámenes que demuestran: hemoglobina: 7,5 g/dl, frotis con esquistocitos, blancos: 6.000 x mm3, plaquetas: 10.000 x mm3, creatinina: 7,5 mg/dl, LDH: 1.200 UI/l, sedimento de orina: microhematuria, proteinuria: 560 mg/día. El diagnóstico de sospecha es:

a. Vasculitis de vaso pequeño
b. Púrpura trombocitopénico inmune
c. Lupus eritematoso sistémico
d. Rabdomiólisis aguda
e. Síndrome urémico puro

Respuesta correcta: b. Púrpura trombocitopénico inmune

Explicación: Tiene un PTT clásico: falla renal aguda, anemia hemolítica, trombocitopenia, afectación del sistema nervioso central y periférico. Puede tener artralgias, fiebre y un sinnúmero de otras alteraciones.

Fuente: Hematología, prueba 5 del 8 de mayo de 2024, P2

77. ¿Cuál es el tratamiento de segunda línea para un paciente diagnosticado de púrpura trombocitopénico inmune crónico, que no responde al tratamiento con corticoides orales?

a. Esplenectomía
b. Corticoides endovenosos
c. Inmunoglobulina G endovenosa
d. Quimioterapia
e. Hidroxiúrea y anagrelide

Respuesta correcta: a. Esplenectomía

Explicación: Es una pregunta discutible, pero en general el PTI crónico se trata con corticoides orales de manera crónica y, si no responde (objetivo de lograra un recuento de plaquetas estable mayor a 20.000 por mm3 y sin hemorragias), se procede a la esplenectomía (90% de éxito aprox.) o al rituximab (50% de éxito aprox. pero sin el riesgo quirúrgico; rituximab son anticuerpos anti-CD20). Eso sí, en caso de estar muy grave, con una diátesis hemorrágica severa, se debe tratar la urgencia con IgG endovenosa en altas dosis (lo más importante para elevar rápido el número de plaquetas) más pulsos de corticoides endovenosos.

Fuente: Hematología, prueba 1 del 8 de mayo de 2024, P5

78. Una paciente de 50 años presenta epistaxis en varias oportunidades en el último mes, asociado a sangramiento de las encías al cepillarse los dientes. Al examen físico se aprecian múltiples petequias generalizadas, con algunas equimosis. No ha presentado otros síntomas. La conducta más adecuada es:

a. Solicitar tiempos de coagulación
b. Solicitar hemograma
c. Solicitar biopsia de piel
d. Iniciar aspirina
e. Iniciar corticoides

Respuesta correcta: b. Solicitar hemograma

Explicación: Tiene clínica de una alteración de la hemostasia primaria (petequias, epistaxis y hemorragias mucosas). Se debe estudiar con un hemograma, para ver el recuento de plaquetas y ver las causas más frecuentes (PTI, leucemia).

Fuente: Hematología, prueba 8 del 8 de mayo de 2024, P5

79. Un niño de 6 años presenta aparición de un exantema. Al examen físico se aprecian numerosas petequias y 5 equimosis de pequeño tamaño. La madre refiere que desde hace una semana presentó fiebre por un par de días y que ha estado con rinorrea y algo de tos. Se solicita un hemograma que muestra hematocrito: 40%, plaquetas: 50.000 x mm3, blancos: 6.000 x mm3, 50% linfocitos, 45% segmentados, 0% baciliformes, 0% mielocitos, 0% promielocitos, 0% de blastos, 5% monocitos. La conducta más adecuada es:

a. Indicar reposo relativo e iniciar aspirina
b. Indicar reposo relativo e iniciar prednisona
c. Realizar transfusión de plaquetas
d. Indicar reposo relativo y observar evolución
e. Administrar inmunoglobulina endovenosa

Respuesta correcta: d. Indicar reposo relativo y observar evolución

Explicación: Tiene una púrpura trombocitopénica inmune, que se puede tratar con observación y reposo relativo o con fármacos. En los casos sin hemorragias (epistaxis, gingivorragia, etc) el manejo suele ser sin fármacos. La prednisona se indica en los casos en que hay epistaxis, púrpura oral y, también, cuando las plaquetas son menores a 30.000 por mm3 (20.000 según algunos textos) con poco acceso a atención médica o imposibilidad de guardar reposo (ej niño muy inquieto). Si bien es una pregunta, hasta cierto punto discutible, en este caso en que no tiene más que pocas equimosis y un rash petequial, lo más correcto es no indicar fármacos. En los casos graves, con hemorragias graves, se da metilprednisolona ev más inmunoglobulina G ev o inmunoglobulina anti-D ev.

Fuente: Hematología, prueba 5 del 8 de mayo de 2024, P6

80. El tratamiento del púrpura trombocitopénico agudo, en un niño, con petequias en las EEII y 80.000 plaquetas por mm3, es:

a. Corticoides orales
b. Ácido acetil salicílico
c. Cumarínicos orales
d. Esplenectomía
e. Reposo y observación

Respuesta correcta: e. Reposo y observación

Explicación: IMPORTANTE APRENDER: Es importante recordar que el objetivo NO es normalizar las plaquetas, sino solo prevenir hemorragias severas. El PTI de los niños suele ser un cuadro autolimitado, que rara vez se complica. Por ello, el tratamiento general es conservador y basta con observar la evolución, indicando reposo físico, aunque el uso de corticoides es una opción midiendo riesgos y beneficios. - La observación suele ser el manejo de pacientes con equimosis, petequias. - Los corticoides orales son una alternativa y están indicados en algunos casos (gingivorragia, epistaxis, otras hemorragias sin urgencia, <20.000 plaquetas o <30.000 más un niño muy inquieto o padres que no tienen mucho acceso al sistema de salud). - Si hubiese hemorragias graves (ej. hemorragia digestiva u otra hemorragia interna que requiera atención médica de urgencia), se indica IgG EV en alta dosis o Ig anti-D, más corticoides endovenosos. - En hemorragias muy graves, con riesgo vital (ej. hemorragia cerebral, shock hipovolémico, etc.), se agregan las transfusiones de plaquetas más la IgG y más los corticoides ev. - El tratamiento de segunda línea solo se usa en PTI crónicos, que no logran un recuento de plaquetas estables >20.000, con el uso de corticoides y, actualmente, se utiliza, la esplenectomía (80-90% éxito, pero quirúrgica y con inmunodepresión secundaria) y el rituximab (50% de éxito, no quirúrgica y también con inmunodepresión secundaria). De los PTI de la infancia solo un 10-20% cronifica y, de esos, cerca de la mitad desaparece en 5 años. En los adultos, en cambio, el 80-90% cronifica. En los adultos, el tratamiento suele ser similar al ya explicado, aunque los corticoides se usan con mayor frecuencia que en los niños. En adultos, con PTI leves, la decisión de observar vs. usar fármacos se toma caso a caso y lo más importante es siempre la clínica.

Fuente: Hematología, prueba 6 del 5 de mayo de 2024, P10

81. Un niño presenta un púrpura petequial, asociado a aparición de equimosis en las extremidades inferiores. La conducta más adecuada es:

a. Iniciar corticoides orales
b. Solicitar un hemograma y controlar ambulatoriamente con el resultado
c. Solicitar una biopsia de médula ósea
d. Iniciar aspirina oral
e. Hospitalizar para estudio

Respuesta correcta: b. Solicitar un hemograma y controlar ambulatoriamente con el resultado

Explicación: Toda púrpura se debe estudiar inicialmente con un hemograma, ya que con ello se puede clasificar en trombocitopénica (ej. PTI) y no trombocitopénica (ej. P. Schönlein Henoch) y además, se pueden detectar algunas causas, como la leucemia aguda. Si hubiese tenido fiebre, la respuesta correcta habría sido hospitalizar para estudio, ya que el púrpura febril es una urgencia (sospecha de meningococcemia o leucemia). Una vez definida la causa, se manejará según diagnóstico (si termina siendo una PTI, probablemente se observará, ya que no tiene manifestaciones que requieran corticoides, a menos que las plaquetas estén muy bajas y sean menores a 30.000).

Fuente: Hematología, prueba 7 del 8 de mayo de 2024, P10

82. Un paciente de 63 años, diagnosticado de artrosis, usuaria de paracetamol e ibuprofeno, consulta por aparición de múltiples petequias en las extremidades inferiores y en el tronco, asociado a epistaxis y algunas equimosis en EEII. Se solicita un hemograma que muestra hematocrito: 45%, hemoglobina: 15 g/dl, plaquetas: 30.000 por mm3, blancos: 7.200 por mm3, con fórmula diferencial normal. El diagnóstico más probable es:

a. Disfunción plaquetaria por ibuprofeno
b. Púrpura trombocitopénico inmune
c. Púrpura trombocitopénico trombótico
d. Hemofilia
e. Enfermedad de Von Willebrand

Respuesta correcta: b. Púrpura trombocitopénico inmune

Explicación: Tiene una alteración de la hemostasia primaria: petequias y hemorragias mucosas. El hemograma muestra trombocitopenia sola, por lo que es un PTI. La A (disfunción plaquetaria) y la E (EvW) tienen hemograma normal. La B (PTT) además tendría anemia hemolítica. La D (hemofilia) tendría alteración de la hemostasia secundaria (coagulación) y hemograma normal.

Fuente: Hematología, prueba 6 del 5 de mayo de 2024, P11

83. El tratamiento de la púrpura trombocitopénica crónica, en un paciente adulto, asintomático y con 50.000 plaquetas por mm3, es:

a. Corticoides orales
b. Ácido acetil salicílico
c. Cumarínicos orales
d. Esplenectomía
e. Prevención de traumatismos, observación de síntomas y seguimiento con recuento de plaquetas

Respuesta correcta: e. Prevención de traumatismos, observación de síntomas y seguimiento con recuento de plaquetas

Explicación: En el tratamiento de primera línea de la PTI crónica con síntomas o menos de 20.000-30.000 plaquetas es la prednisona oral. Si sigue con plaquetas muy bajas, se indica la esplenectomía o el rituximab. Si tiene hemorragias graves, se indica la IgG endovenosa en altas dosis más pulsos de corticoides endovenosos (ej. metilprednisolona). - Actualmente es perfectamente factible observar y seguir con hemogramas a un paciente adulto con PTI crónico, sin síntomas.

Fuente: Hematología, prueba 3 del 8 de mayo de 2024, P20

Coagulopatías y hemofilia (5)

84. Usted recibe a un niño de 4 años, que ha presentado dos hematomas musculares y múltiples equimosis, ante mínimos traumatismos, desde hace 2 días. Previo a eso no había tenido síntomas de ese tipo. Se solicita un hemograma, que resulta normal, TP que está muy alargado y TTPA que está normal. El diagnóstico más probable es:

a. Púrpura trombocitopénico trombótico
b. Púrpura trombocitopénico inmune
c. Intoxicación con cumarínicos
d. Hemofilia A

e. Enfermedad de Von Willebrand

Respuesta correcta: c. Intoxicación con cumarínicos

Explicación: Es una pregunta difícil, ya que hay que conocer los distintos trastornos de la hemostasia. - El PTT tendría trombopenia y anemia hemolítica. - El PTI tendría trombopenia, con TP y TTPA normales. - La intoxicación con cumarínicos (ej. comerse el veneno de ratas o los medicamentos de la abuela) alarga el TP tiene hemograma normal, ya que genera un trastorno de la hemostasia secundaria (coagulación). Se trata con vitamina K y, en los casos con hemorragias severas, se da plasma fresco congelado para una inmediata recuperación. - La hemofilia tiene hemograma normal, pero alarga el TTPA, con TP normal. Además, los síntomas estarían presentes desde el nacimeinto. - La EvW afecta la función plaquetaria, por lo que tiene hemograma normal, pero también normalidad del TP y TTPA, alargando el tiempo de sangría (alteración de la hemostasia secundaria). Solo en algunos casos alarga el TTPA (el FvW se une al F.VIII). Por ser genética, la EvW suele tener síntomas crónicos, aunque en los casos leves pueden pasar algo desapercibidos.

Fuente: Hematología, prueba 1 del 8 de mayo de 2024, P7

85. Un niño de 2 años presenta una hemartrosis de rodilla, en relación a un golpe de moderada intensidad. Además, ha presentado varios hematomas profundos (musculares) y al examen físico se aprecian equimosis en varias zonas de la piel. ¿Qué examen estará alterado con mayor probabilidad?

a. Hemograma
b. Pruebas de agregación plaquetaria
c. Tiempo de tromboplastina parcial activada
d. Tiempo de sangría
e. Niveles plasmáticos de antitrombina III

Respuesta correcta: c. Tiempo de tromboplastina parcial activada

Explicación: La sospecha diagnóstica es una hemofilia (niño con hemartrosis y hematomas profundos, que son manifestaciones de las alteraciones de la hemostasia secundaria). Tanto la hemofilia A como la B alargan el TTPA. Se debe solicitar F.VIII (bajo en la hemofilia A) y F.IX (bajo en la hemofilia B). Dado que es una condición genética, que está presente desde el nacimiento, la hemofilia se suele diagnosticar durante el primer año de vida en los casos graves. En los casos más leves, el diagnóstico puede ser más tardío. Son frecuentes los antecedente familiares de varones con hemofililia o muertes neonatales por hemorragias. - Las pruebas de agregación plaquetarias están alteradas en la enfermedad de von Willebrand y otras patologías de disfunción plaquetaria, como la enfermedad de Bernard Soulier, la enfermedad de Glanzmann y, como algo importante, también se alteran en el uso de aspirina y otros AINEs.

Fuente: Hematología, prueba 3 del 8 de mayo de 2024, P10

86. ¿Cuál de las siguientes opciones es más sugerente de hemofilia?

a. Hipermenorrea
b. Petequias y equimosis
c. Presencia de hemartrosis y hematomas profundos
d. Alargamiento del tiempo de protrombina
e. Alargamiento del tiempo de sangría

Respuesta correcta: c. Presencia de hemartrosis y hematomas profundos

Explicación: La hemofilia es una alteración de la hemostasia secundaria, es decir, de la coagulación, lo que se caracteriza por hematomas profundos y hemartrosis, además de equimosis espontáneas o ante

traumas menores. Por ser una enfermedad genética en que falta el factor de coagulación VIII (hemofilia A) o IX (hemofilia B), puede presentarse desde el nacimiento mismo, con cefalohematomas, hemorragias intracraneales, equimosis. A largo plazo puede haber daño neurológico o articular, debido a las hemorragias cerebrales y articulares, respectivamente. Además, alarga el TTPA (tiempo de tromboplastina parcial activada). En cambio, el TP y el recuento de plaquetas están normales. La hipermenorrea, petequias y alargamiento del tiempo de sangría se ven en las alteraciones de la hemostasia primaria (plaquetas). El TP se alarga en el daño hepático crónico y en el uso de TACO (cumarínicos). La hemofilia se confirma con la medición del factor VIII y factor IX o con pruebas genéticas. Las mujeres portadoras (heterocigotas) no suelen tener síntomas y solo se les da consejería genética, respecto al riesgo de sus hijos: niños tendrán 50% de riesgo de tener hemofilia; y las niñas tendrán 0% de riesgo de tener hemofilia, pero, 50% de riesgo de ser portadoras.

Fuente: Hematología, prueba 8 del 8 de mayo de 2024, P10

87. Un niño presenta una hemartrosis de rodilla, en relación a un golpe de moderada intensidad. Además, ha presentado varios hematomas profundos (musculares) y al examen físico se aprecian equimosis en varias zonas de la piel. ¿Qué examen estará alterado con mayor probabilidad?

a. Pruebas de agregación plaquetaria
b. Tiempo de tromboplastina parcial activada
c. Niveles plasmáticos de antitrombina III
d. Hemograma
e. Tiempo de sangría

Respuesta correcta: b. Tiempo de tromboplastina parcial activada

Explicación: La sospecha diagnóstica es una hemofilia (niño con hemartrosis y hematomas profundos, que son manifestaciones de las alteraciones de la hemostasia secundaria). Tanto la hemofilia A, como la B alargan el TTPA. Las pruebas de agregación plaquetarias están alteradas en la enfermedad de von Willebrand.

Fuente: Hematología, prueba 4 del 8 de mayo de 2024, P18

88. Un niño de 3 años presenta una hemartrosis de rodilla, en relación a un golpe de moderada intensidad. Además, ha presentado varios hematomas profundos (musculares) y al examen físico se aprecian equimosis en varias zonas de la piel. ¿Qué diagnóstico es el más probable?

a. Púrpura trombocitopénico inmune
b. Enfermedad de Von Willebrand
c. Hemofilia
d. Leucemia aguda
e. Déficit de antitrombina III

Respuesta correcta: c. Hemofilia

Explicación: Es una hemofilia clásica: niño con clínica de alteración de la hemostasia secundaria (hemartrosis y hematomas profundos). El PTI, EvW y leucemia producen alteración de hemostasia primaria (petequias, espistaxis y hemorragias mucosas). El déficit de ATIII es una trombofilia (produce TVP y TEP). En algunos casos de EvW, más graves (infrecuentes), puede tener una clínica similar a la hemofilia e incluso puede tener disminución del F VIII de la coagulación, ya que el FvW y el FVIII suelen unirse. Por eso, se recomienda descartar EvW en toda hemofilia A.

Fuente: Hematología, prueba 6 del 5 de mayo de 2024, P20

Trombofilias y terapia anticoagulante (11)

89. El síndrome antifosfolípido se caracteriza por:

a. Alargamiento del tiempo de protrombina
b. Alargamiento del tiempo de tromboplastina parcial activada
c. Alargamiento del tiempo de sangría
d. Alteración de las pruebas de agregación plaquetaria
e. Disminución del recuento de plaquetas

Respuesta correcta: b. Alargamiento del tiempo de tromboplastina parcial activada

Explicación: El SAF es una enfermedad autoinmune, asociada a lupus sistémico y que produce abortos y trombosis, tanto venosas, como arteriales. Se caracteriza por tener VDRL falsamente positivo y alargar el TTPA, lo que se conoce como "anticoagulante lúpico". Sus marcadores más específicos son los anticuerpos anticardiolipinas y antifosfolípidos.

Fuente: Hematología, prueba 4 del 8 de mayo de 2024, P3

90. Una paciente de 23 años, estudiante universitaria, sin antecedentes de importancia, presenta dolor en la pierna izquierda, por lo que consulta. Al examen físico tiene edema de la pierna izquierda y dolor a la palpación de los músculos gastrognemios y también a la dorsiflexión del pie. Niega haber realizado actividad física o movimientos que pudieran haber generado el dolor. ¿Qué examen es el más adecuado para proseguir el estudio?

a. VDRL más anticuerpos antifosfolípidos y anticardiolipinas
b. AngioTAC de tórax
c. Hemograma
d. Ecografía doppler de extremidades inferiores
e. Tiempo de tromboplastina parcial activada y tiempo de protrombina

Respuesta correcta: d. Ecografía doppler de extremidades inferiores

Explicación: La sospecha diagnóstica es una trombosis venosa profunda, por lo que se debe confirmar con una ecografía doppler y anticoiagular con heparina de bajo peso molecular. Más adelante se estudiará la causa de la trombofilia, incluyendo los anticuerpos antifosfolípidos, pero lo primero es confirmar la TVP.

Fuente: Hematología, prueba 5 del 8 de mayo de 2024, P7

91. Un paciente de 40 años, sufre una TVP, la que se confirma con un Eco-Doppler de EEII. Se inicia estudio de trombofilias, siendo diagnosticado de un factor V de Leiden. Está en buenas condiciones generales y su examen físico es compatible con una TVP de la pierna izquierda, sin otras alteraciones. La conducta más adecuada es:

a. Hospitalizar, anticoagular con heparina y luego iniciar anticoagulación oral con cumarínicos
b. Hospitalizar, indicar reposo absoluto e instalar un filtro de vena cava inferior
c. Enviar a domicilio con clopidogrel oral e indicar reposo
d. Enviar a domicilio con vitamina K e indicar reposo
e. Enviar a domicilio con aspirina oral e indicar reposo

Respuesta correcta: a. Hospitalizar, anticoagular con heparina y luego iniciar anticoagulación oral con cumarínicos

Explicación: El tratamiento de la TVP, del TEP y de las trombofilias en general, es la anticoagulación. Se inicia con heparina y se pasa luego a cumarínicos o NACO (nuevos anticoagulantes orales no cumarínicos),

buscando mantener el INR entre 2 y 3 (si están con cumarínicos, ya que los NACO no requieren control). Si la anticoagulación estuviera contraindicada (ej. hemorragia digestiva, AVE hemorrágico, politraumatismo), se debe instalar un filtro de vena cava inferior. Si, además, de la TVP o TEP, se identifica un trombofilia genética, como en este caso, la anticoagulación se mantiene de por vida.

Fuente: Hematología, prueba 2 del 8 de mayo de 2024, P8

92. El síndrome antifosfolípido se caracteriza por:

a. Alargamiento del tiempo de sangría
b. Alargamiento del tiempo de protrombina
c. Alargamiento del tiempo de tromboplastina parcial activada
d. Disminución del recuento de plaquetas
e. Alteración de las pruebas de agregación plaquetaria

Respuesta correcta: c. Alargamiento del tiempo de tromboplastina parcial activada

Explicación: El SAF es una enfermedad autoinmune, que puede ser primario o asociado a lupus sistémico y que produce 1. problemas relacionados al embarazo (abortos, preclamsia, insuficiencia placentaria) y 2. trombosis (tanto venosas como arteriales). Para ser un síndrome propiamente tal, requiere de eventos clínicos y no solo de la presencia de marcadores. Se caracteriza por tener los siguientes marcadores: - VDRL falsamente positivo. - Anticoagulante lúpico, que alarga el TTPA. - Anticuerpos más específicos: anticuerpos anticardiolipinas, anticuerpos antifosfolípidos y anticuerpos antibeta-2 glicoproteína. El tratamiento suele ser: - Con anticoagulación de por vida en todos los pacientes con eventos embólicos (se prefieren cumarínicos). - En los casos en que solo tiene historia de mal resultado obstétricos, se indica aspirina más heparina de bajo peso molecular durante el embarazo. - En los casos en que solo tiene los marcadores, sin síntomas, no se ha demostrado beneficio de los fármacos y se pueden observar.

Fuente: Hematología, prueba 6 del 5 de mayo de 2024, P8

93. Un paciente presenta disminución de la proteína S. Tendrá alto riesgo de:

a. Hemorragias
b. Infecciones
c. Leucemia
d. Linfoma
e. Trombosis

Respuesta correcta: e. Trombosis

Explicación: El déficit de proteína S es una trombofilia, dado que la proteína S es una proteína anticoagulante. El déficit de proteína C y déficit de antitrombina III también son trombofilias.

Fuente: Hematología, prueba 3 del 8 de mayo de 2024, P9

94. Un paciente presenta un TEP, que es manejado con heparina endovenosa y posteriormente tratamiento anticoagulante oral, con acenocumarol. ¿Qué examen es el más adecuado para ajustar la dosis del acenocumarol?

a. Tiempo de sangría
b. Tiempo de tromboplastina parcial activada
c. INR (International Normalized Ratio)
d. Recuento de plaquetas
e. No necesita ningún examen, ya que la dosis se determina según el peso y la evolución clínica

Respuesta correcta: c. INR (International Normalized Ratio)

Explicación: La dosis de cumarínicos se ajusta según el INR, buscándose que esté entre 2 y 3. El INR es una forma estandarizada de mostrar el tiempo de protrombina (TP). El tiempo de sangría se alarga en las alteraciones de hemostasia primaria. El TTPA (opción B) se usa para ajustar la dosis de heparina no fraccionada, en cambio la de bajo peso molecular no requiere control (opción E).

Fuente: Hematología, prueba 7 del 8 de mayo de 2024, P9

95. La trombofilia congénita más frecuente es:

a. Factor V de Leiden
b. Déficit de antitrobina III
c. Déficit de proteína C
d. Déficit de proteína S
e. Hiperhomocisteinemia

Respuesta correcta: a. Factor V de Leiden

Explicación: El factor V de Leiden, también se llama resistencia a la proteína C y es la más frecuente de las trombofilias congénitas. Sin embargo, no está de más recordar, que las trombofilias secundarias o adquiridas (cáncer, fármacos, síndrome antifosfolípidos, etc.) son todavía mucho más frecuentes que las trombofilias primarias o congénitas.

Fuente: Hematología, prueba 7 del 8 de mayo de 2024, P11

96. Un paciente presenta disminución de la proteína S. Tendrá alto riesgo de:

a. Hemorragias
b. Trombosis
c. Infecciones
d. Leucemia
e. Linfoma

Respuesta correcta: b. Trombosis

Explicación: El déficit de proteína S es una trombofilia, dado que la proteína S es una proteína anticoagulante.

Fuente: Hematología, prueba 4 del 8 de mayo de 2024, P17

97. El síndrome antifosfolípidos se asocia a todo lo siguiente EXCEPTO:

a. Acortamiento del TTPA
b. Trombosis arteriales
c. Trombosis venosas
d. Abortos
e. Lupus eritematosos sistémico

Respuesta correcta: a. Acortamiento del TTPA

Explicación: El SAF es una trombofilia adquirida, de causa autoinmune, que se asocia al lupus sistémico y se caracteriza por malos resultado obstétricos (abortos, preclamsia y partos prematuros) y trombosis tanto arteriales como venosas. Suele alargar el TTPA (lo que se conoce como "anticoagulante lúpico") y suele tener el VDRL falsamente positivo. Finalmente sus marcadores son los anticuerpos anticardiolipinas, antifosfolípidos y antibeta- 2 glicoproteína. - La sola presencia de marcadores se puede observar (no sería

un SAF, al no tener los síntomas y signos definitorios de todo síndrome). - Si solo se manifiesta con síntomas obstétricos, se debe anticoagular (con heparina de bajo peso molecular) más aspirina en baja dosis, pudiendo suspenderse al terminar el embarazo. - Si tiene eventos trombóticos, se trata con anticoagulación a permanencia, preferentemente con cumarínicos por sobre los NACO. - Si tiene lupus asociado, obviamente se debe tratar también el lupus.

Fuente: Hematología, prueba 3 del 8 de mayo de 2024, P18

98. Un paciente presenta resistencia del factor V a la acción de la proteína C. Tendrá alto riesgo de:

a. Hemorragias
b. Infecciones
c. Leucemia
d. Linfoma
e. Trombosis

Respuesta correcta: e. Trombosis

Explicación: La resistencia a la proteína C o factor V de Leiden es la trombofilia congénita más frecuente (las adquiridas son más frecuentes aun).

Fuente: Hematología, prueba 6 del 5 de mayo de 2024, P19

99. El síndrome antifosfolípidos se asocia a todo lo siguiente EXCEPTO:

a. Abortos
b. Lupus eritematosos sistémico
c. Acortamiento del TTPA
d. Trombosis arteriales
e. Trombosis venosas

Respuesta correcta: c. Acortamiento del TTPA

Explicación: El SAF es una trombofilia adquirida, de causa autoinmune, que se asocia al lupus sistémico y se caracteriza por malos resultado obstétricos (abortos, preclamsia y partos prematuros) y trombosis tanto arteriales como venosas. Suele alargar el TTPA (lo que se conoce como "anticoagulante lúpico") y suele tener el VDRL falsamente positivo. Finalmente sus marcadores son los anticuerpos anticardiolipinas, antifosfolípidos y antibeta- 2 glicoproteína. - La sola presencia de marcadores se puede observar (no sería un SAF, al no tener los síntomas y signos definitorios de todo síndrome). - Si solo se manifiesta con síntomas obstétricos, se debe anticoagular (con heparina de bajo peso molecular) más aspirina en baja dosis, pudiendo suspenderse al terminar el embarazo. - Si tiene eventos trombóticos, se trata con anticoagulación a permanencia, preferentemente con cumarínicos por sobre los NACO. - Si tiene lupus asociado, obviamente se debe tratar también el lupus.

Fuente: Hematología, prueba 4 del 8 de mayo de 2024, P20

Alteraciones reactivas del hemograma (4)

100. Un paciente de 45 años presenta un cuadro de fiebre y malestar general, de 5 días de evolución. Su hemograma muestra Hemoglobina: 14 g/dl, plaquetas: 400.000 por mm3, blancos: 16.000 por mm3, con 10% de linfocitos, 5% de monocitos y 70% de neutrófilos segmentados y 15% de baciliformes. El diagnóstico más probable es:

a. Infección viral
b. Infección bacteriana

c. Leucemia aguda
d. Leucemia mieloide crónica
e. Linfoma

Respuesta correcta: b. Infección bacteriana

Explicación: Es una infección bacteriana clásica: leucocitosis de predominio neutrofílico, con desviación izquierda. Tiene normalidad de los glóbulos y plaquetas, aunque es frecuente que haya trombocitosis en los cuadros inflamatorios (trombocitosis reactiva). La LMC habría tenido mayor leucocitosis (mayor a 20.000), y un cuadro de más días de evolución. Vale la pena recordar que muchas veces es imposible diferenciar una LMC de una reacción leucemoide, secundaria a una infección bacteriana, razón por la cual se busca activamente el cromosoma Filadelfia con hibridación in situ o PCR para confirmar el diagnóstico de LMC. Eso sí, en este caso, la sospecha no es una LMC, sino solo una infección bacteriana.

Fuente: Hematología, prueba 3 del 8 de mayo de 2024, P3 · Hematología, prueba 6 del 5 de mayo de 2024, P13

101. Un niño de 2 años presenta un cuadro de mialgias, fiebre alta y odinofagia. Los padres lo tratan inicialmente con paracetamol, pero 4 días después continúa con fiebre sobre 38,5ºC, por lo que deciden consultar. Su faringe se aprecia eritematosa y se palpan adenopatías cervicales, sin otras alteraciones. Se solicita un hemograma que muestra hematocrito: 39%, hemoglobina: 12,8 g/dl, VCM: 91 ft, blancos: 17.900 x mm3, con 75% de linfocitos, 18% de neutrófilos, 3% de monocitos y 2% de eosinófilos y plaquetas: 150.000 x mm3. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

a. Reacción leucemoide
b. Linfoma
c. Leucemia linfática aguda
d. Leucemia linfática crónica
e. Infección viral

Respuesta correcta: e. Infección viral

Explicación: Tiene clínica de infección respiratoria alta y un hemograma con linfocitosis, sin otras alteraciones, por lo que todo apunta a un cuadro viral. Por la sintomatología y la edad parece un adenovirus (también podría ser un metaneumovirus o incluso una influenza). No había razón para pedirle el hemograma, ya que llevaba poco tiempo con los síntomas y había muchos elementos que hacían sospechar una causa infecciosa viral. Las reacciones leucemoides requieren más de 50.000 blancos (algunos autores ponen como corte 30.000).

Fuente: Hematología, prueba 5 del 8 de mayo de 2024, P5

102. Un paciente de 55 años presenta una celulitis en el pie izquierdo, la que se trata con cloxacilina y ketoprofeno. Se solicita un hemograma que demuestra leucocitosis de 15.000 con desviación izquierda, sin embargo, llama la atención el número de plaquetas, que asciende a 550.000 por mm3. ¿Cuál es la causa más probable de su trombocitosis?:

a. Reactiva, secundaria a la inflamación
b. Autoinmune
c. Secundaria a la cloxacilina
d. Trombocitosis esencial
e. Secundaria al ketoprofeno

Respuesta correcta: a. Reactiva, secundaria a la inflamación

Explicación: La causa más frecuente de elevación de las plaquetas es de tipo reactiva, en especial, secundaria a la inflamación (las plaquetas son reactantes de fase aguda). Así que, si existe una causa evidente de inflamación, como en este caso, la trombocitosis reactiva debe ser sospechada en primer lugar. Vale la pena mencionar que reportes recientes demuestran que incluso los niveles de plaquetas muy elevados (ej. sobre 1.000.000 de plaquetas por mm3) siguen siendo causados, en primer lugar, por causas reactivas, por lo que lo primero siempre es tratar la causa de base. Solo cuando la trombocitosis persiste, cuando no hay una causa reactiva que la explique, o cuando hay otras alteraciones en el hemograma (ej. sugerentes de LMC), se estudian con mayor profundidad (descartar trombocitosis esencial, por ejemplo, con gen JAK2, biopsia de médula ósea, etc). Otra causa de trombocitosis reactiva es la ferropenia, por lo que siempre se debe pedir ferritina en los casos de trombocitosis que persiste después de tratar las posibles causas infecciosas o inflamatorias. Los AINES (Ketoprofeno) no producen alteración en el número de plaquetas, sino que producen una disfunción plaquetaria (alteran su funcionamiento).

Fuente: Hematología, prueba 3 del 8 de mayo de 2024, P13 · Hematología, prueba 7 del 8 de mayo de 2024, P18

103. Un paciente de 55 años presenta una celulitis en el pie izquierdo, la que se trata con cloxacilina y ketoprofeno. Se solicita un hemograma que demuestra leucocitosis de 15.000 con desviación izquierda, sin embargo, llama la atención el número de plaquetas, que asciende a 895.000 por mm3. ¿Cuál es la causa más probable de su trombocitosis?

a. Secundaria a la cloxacilina
b. Secundaria al ketoprofeno
c. Trombocitosis esencial
d. Reactiva, secundaria a la inflamación
e. Autoinmune

Respuesta correcta: d. Reactiva, secundaria a la inflamación

Explicación: Las plaquetas son reactantes de fase aguda, por lo que es normal que se eleven en procesos inflamatorios, como una infección. Además, la trombocitosis reactiva es la causa más frecuente de trombocitosis, por lo que debe marcarse si existe una causa que la explique de manera evidente, como en este caso. Aunque históricamente se enseñaba que las plaquetas sobre 600.000 orientaban a una trombocitosis esencial u otra causa neoplásica (ej. LMC o policitemia vera), actualmente se sabe que número de plaquetas no es un elemento que distinga entre causas reactivas y causas neoplásicas. Es más, algún estudio mostró que el 75% de los casos de trombocitosis mayores a 1.000.000 por mm3 se debían a causas reactivas. Por tanto, si hay una causa identificable, como en este caso, lo más probable es que sea reactiva y solo se sospechan las causas neoplásicas cuando la trombocitosis persiste, a pesar de resolver la causa de base.

Fuente: Hematología, prueba 4 del 8 de mayo de 2024, P19

Oncología general (5)

104. Identifique la asociación CORRECTA entre el cáncer y el factor pronóstico más importante:

a. El tamaño del tumor - Cáncer de tiroides
b. La presencia de adenopatías - Cáncer gástrico
c. El tamaño del tumor - Cáncer de mama
d. El grado histológico de diferenciación - Sarcoma
e. La presencia de metástasis a distancia - Linfoma de Hodgkin

Respuesta correcta: d. El grado histológico de diferenciación - Sarcoma

Explicación: El grado histológico de diferenciación es el factor pronóstico más importante, en el sarcoma de partes blandas. De hecho, se clasifican en G1, G2 y G3, siendo el G3 el menos diferenciado y más agresivo. Respecto a los demás, los factores pronósticos más importantes son: Cáncer de tiroides: tipo histológico. Cáncer gástrico: invasión transmural. Cáncer de mama: compromiso linfático (axila). Linfoma de Hodgkin: tipo histológico (depleción linfocitaria es el tipo de peor pronóstico).

Fuente: Hematología, prueba 6 del 5 de mayo de 2024, P2

105. El factor pronóstico más importante del cáncer de laringe es:

a. Presencia de metástasis a distancia
b. Tamaño del tumor
c. Invasión de los ganglios linfáticos cervicales
d. Tipo histológico
e. Grado de diferenciación histológica

Respuesta correcta: c. Invasión de los ganglios linfáticos cervicales

Explicación: En general, el factor pronóstico más importante en todos los cánceres de cabeza y cuello es el compromiso ganglionar del cuello. Sin embargo, en el cáncer de laringe, en específico, también es muy relevante la ubicación del tumor, ya que el cáncer glótico tiene mejor pronóstico que el supraglótico e infraglótico, ya que da síntomas precoces y tiene una diseminación linfática más lenta.

Fuente: Hematología, prueba 4 del 8 de mayo de 2024, P7

106. La segunda causa de muerte en la edad pediátrica es el cáncer. ¿Cuáles son los tipos de cáncer que con mayor frecuencia causan la muerte en esta edad?

a. Hematológicos y del sistema nervioso
b. Hematológicos y nefrourológicos
c. Hematológicos y digestivos
d. Digestivos y nefrourológicos
e. Hematológicos y sarcomas

Respuesta correcta: a. Hematológicos y del sistema nervioso

Explicación: Los hematológicos son los más frecuentes (50% de las muertes por cáncer en edad pediátrica), aunque hoy en día existe tratamiento con intención curativa para la mayoría de los casos pediátricos con leucemia. Los del sistema nervioso, como los astrocitomas, meduloblastoma y neuroblastoma, son los segundos en frecuencia como causa de muerte (cerca de 25% de las muertes por cáncer en edad pediátrica). El pronóstico es muy variado, dependiendo del tipo de cáncer.

Fuente: Hematología, prueba 3 del 8 de mayo de 2024, P11

107. El factor pronóstico más importante en el cáncer de colon es actualmente la invasión transmural. ¿Cuál es el factor pronóstico más importante en el Cáncer GÁSTRICO?

a. También es la invasión transmural
b. La presencia de adenopatías
c. El tamaño del tumor
d. El grado histológico de diferenciación
e. La presencia de metástasis a distancia

Respuesta correcta: a. También es la invasión transmural

Explicación: En todo el tubo digestivo, desde el esófago, hasta el recto, es la invasión transmural.

Fuente: Hematología, prueba 3 del 8 de mayo de 2024, P12

108. El factor pronóstico más importante del cáncer de laringe es:

a. Tipo histológico
b. Invasión de los ganglios linfáticos cervicales
c. Grado de diferenciación histológica
d. Presencia de metástasis a distancia
e. Tamaño del tumor

Respuesta correcta: b. Invasión de los ganglios linfáticos cervicales

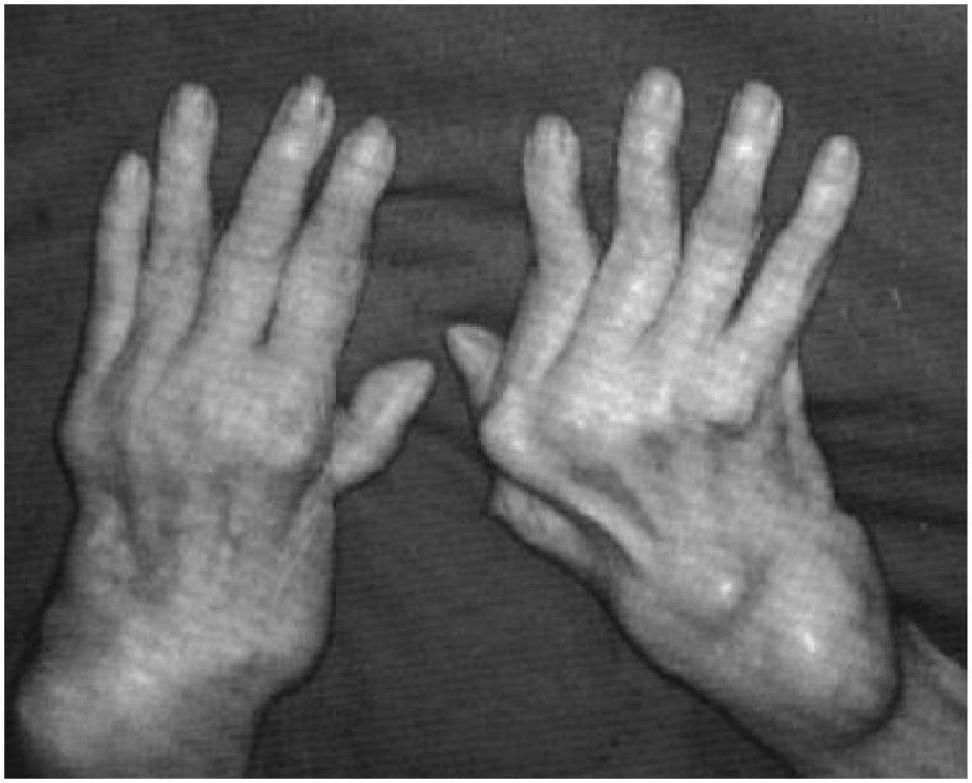
Explicación: En general, el factor pronóstico más importante en todos los cánceres de cabeza y cuello es el compromiso ganglionar del cuello. Sin embargo, en el cáncer de laringe, en específico, también es muy relevante la ubicación del tumor, ya que el cáncer glótico tiene mejor pronóstico que el supraglótico e infraglótico, ya que da síntomas precoces y tiene una diseminación linfática más lenta.

Fuente: Hematología, prueba 7 del 8 de mayo de 2024, P19

Reumatología (56)

Artritis reumatoide (6)

1. Una paciente de 65 años acude al policlínico, acusando dolor en las manos y otras articulaciones. Al examen físico se aprecian deformaciones en ambas manos, como se muestra en la imagen. El diagnóstico más probable es:



a. Artrosis
b. Artritis reumatoide
c. Artritis psoriática
d. Condrocalcinosis
e. Gota

Respuesta correcta: b. Artritis reumatoide

Explicación: Es una artritis reumatoide (AR) clásica. Tiene afectación de las muñecas y metacarpofalángicas (rara vez afectadas por artrosis, pero características de la AR) y además, se observan las deformaciones características: dedos en ráfaga cubital y dedos en cuello de cisne (en esta foto no se ven los dedos en sastre). La presentación clásica de esta enfermedad incluye lo siguiente: 1. Poliartritis simétrica de más de 6 semanas (importante que tenga signos inflamatorios), con rigidez matinal. 2. Elevación de parámetros inflamatorios (VHS y PCR). 3. Presencia de FR o anticuerpos anti-CCP (ambos con 80% de sensibilidad; el anti- CCP es más específico que el FR). 4. Evolución a deformación articular (artritis erosiva, con osteopenia yuxtaarticular en la radiografía). 5. Algunos casos tienen síntomas sistémicos: nódulos reumatoideos, fiebre, baja de peso, derrame pleural (exudado con ADA alta y predominio mononuclear), síndrome de Sjögren secundario, infrecuente afectación cardíaca: pericarditis y

miocarditis). - Pero, hay casos que no cumplen con las 6 semas, casos que tienen marcadores negativos y casos que están sin inflamación actual y que solo tienen la historia previa o las deformaciones clásicas.

Fuente: Reumatología, cuestionario 6.1, P3

2. Una paciente de 45 años consulta por artralgias de manos, de 3 meses de evolución, que han ido en aumento y que se asocian a marcada rigidez matinal, que dura cerca de 2 horas. Al examen físico se aprecia eritema y de varias articulaciones metacarpofalángicas e interfalángicas proximales de ambas manos. Se solicita radiografía de manos, de la que a continuación se muestra un acercamiento de las segunda y tercera articulaciones metacarpofalángicas derechas. El diagnóstico más probable es:

a. Artritis psoriática
b. Artritis reumatoide
c. Lupus sistémico
d. Artrosis
e. Condrocalcinosis

Respuesta correcta: b. Artritis reumatoide

Explicación: La clínica es una AR clásica y con ello es suficiente para establecer el diagnóstico (poliartritis crónica, simétrica, con afectación de las manos y rigidez matinal). La afectación de las articulaciones MCF también la sugiere. De todos modos, la radiografía muestra erosiones en ambas articulaciones MCF, por lo que sugiere aún más una AR, ya que se caracteriza por tener artritis erosiva. - Se debe solicitar FR, anti-CCP y ANA (solo por si acaso) e iniciar inmediatamente el tratamiento con DMAR (drogas modificadoras de la AR), idealmente el metotrexato en dosis semanal. - Los corticoides, AINEs y paracetamol están plenamente indicados como tratamiento sintomático, en especial al inicio y durante los brotes, ya que las DMARs demoran en iniciar su efecto. Sin embargo, el uso de tratamiento sintomático, no debe retrasar el inicio de DMARs. - A modo de cultura general, en los casos que el MTX no funciona, se suele cambiar por otro DMAR (leflunomida, azatioprina, hidroxicloroquina, sulfasalazina). Si no funciona, se mezclan 2 o 3. Si no funciona, la última línea son los medicamentos biológicos, en especial los anticuerpos contra el receptor de TNF-alfa (etanercept, adalimumab o infliximab). - En el embarazo, se usan los medicamentos biológicos (se debe saber).

Fuente: Reumatología, cuestionario 6.1, P12

3. Una paciente de 53 años comienza con dolor en las articulaciones de las manos y muñecas, que inició hace 2 meses y que ha ido en aumento. Despierta con rigidez de manos, la que dura cerca de una hora y al examen físico se aprecia artritis de muñecas y varias articulaciones metacarpofalángicas. Se solicita un hemograma, que resulta normal, al igual que la radiografía de manos. ¿Qué diagnóstico es más probable?

a. Artrosis
b. Enfermedad mixta del tejido conectivo
c. Síndrome de CREST
d. Artritis reumatoide
e. Artritis psoriática

Respuesta correcta: d. Artritis reumatoide

Explicación: Es una AR clásica, por la clínica: poliartritis crónica de manos, simétrica, con compromiso de las muñecas y articulaciones MCF (además suele afectar a las IFP: interfalángicas proximales) y rigidez matinal mayor a 30 minutos. Que la radiografía esté normal, no hace gran diferencia. Lo mismo si es que los marcadores (FR y anti-CCP) estuviesen negativos, ya que lo más importante es la clínica. Sin embargo, los marcadores positivos o la radiografía con erosiones articulares apoyarían aún más el diagnóstico

(siempre y cuando la clínica fuera compatible). La elevación de los parámetros inflamatorios (PCR y VHS) es un indicador de actividad, que suele estar presente, por lo que se incluye dentro de los criterios diagnósticos. Sin embargo, son muy inespecíficos. En este caso, se debe solicitar FR, anticuerpos antipéptido citrulinado (anti-CCP), ANA (para el diagnóstico diferencial), PCR, VHS. El hemograma suele mostrar anemia de enfermedades crónicas. Las plaquetas pueden estar elevadas (trombocitosis reactiva), aunque, puede estar baja, si se agrega una PTI secundaria (más rara y sugerente de lupus, pero que se puede ver en AR).

Fuente: Reumatología, cuestionario 6.2, P2

4. ¿Cuál de las siguientes es una manifestación extraarticular de la artritis reumatoide?

a. Glomerulonefritis aguda
b. Fibrosis pulmonar
c. Eritema nodoso
d. Meningitis aséptica
e. Mielitis transversa

Respuesta correcta: b. Fibrosis pulmonar

Explicación: La AR se manifiesta extrarticularmente como nódulos reumatoides, afectación de cualquiera de las 3 capas del corazón (raro), derrame pleural (exudado mononuclear con ADA elevada, igual al derrame TBC), fibrosis pulmonar, escleritis/epiescleritis (también uveítis, aunque es más rara) y una vasculitis sistémica (fiebre, rash y mononeuritis múltiple, aunque es rara). - Por regla general no tiene afectación renal ni del sistema nervioso central (las que son sugerentes de LES; aunque la mielitis también se ve en el síndrome de Sjögren). - El eritema nodoso es propio de la sarcoidosis y la espondilitis anquilosante. - Además, vale la pena recordar que casi todas las enfermedades autoinmunes producen fibrosis pulmonar.

Fuente: Reumatología, cuestionario 6.2, P8

5. Una paciente de 59 años presenta artralgias desde hace varios años. Al examen físico sus manos se observan de la siguiente manera: El diagnóstico más probable es:

a. Artrosis
b. Artritis psoriática
c. Artritis reumatoide
d. Gota
e. Condrocalcinosis

Respuesta correcta: c. Artritis reumatoide

Explicación: Es una artritis reumatoide (AR) clásica. Tiene gran afectación de las metacarpofalángicas (rara vez afectadas por artrosis, pero características de la AR) y además, se observan las deformaciones características: dedos en cuello de cisne (en esta foto no se ven los dedos en sastre, ni la ráfaga cubital).

Fuente: Reumatología, cuestionario 6.3, P1

6. Una paciente de 45 años consulta por artralgias de 2 meses de evolución, que han ido en aumento. Las articulaciones más comprometidas son las interfalángicas proximales, mecarpofalángicas y las muñecas, aunque también presenta dolor en las metatarsofalángicas, la rodilla derecha y el codo izquierdo. Al examen físico se aprecia aumento de volumen, eritema y signos de derrame articular de varias de las articulaciones descritas. El diagnóstico más probable es:

a. Lupus sistémico

b. Artritis reumatoide
c. Artrosis
d. Artritis viral
e. Condrocalcinosis

Respuesta correcta: b. Artritis reumatoide

Explicación: Es una AR clásica, por la clínica: poliartritis crónica de manos, simétrica, con compromiso de las muñecas y articulaciones MCF (además suele afectar a las IFP: interfalángicas proximales y cursar con rigidez matinal mayor a 30 minutos). No tiene otros síntomas, como para pensar en lupus. No puede ser artrosis, porque la artrosis no tiene artritis, es decir, no tiene signos inflamatorios en las articulaciones. Además, cuando afecta las manos, la artrosis afecta las articulaciones interfalángicas distales y proximales. La artritis viral podría tener la misma clínica, pero de manera aguda y no crónica, como en este caso (los virus producen una poliartritis aguda). La condrocalcinosis se caracteriza por monoartritis (o, a lo más, oligoartritis) migratoria (al igual que la gota).

Fuente: Reumatología, cuestionario 6.3, P9

Lupus eritematoso sistémico y conectivopatías (8)

7. Una paciente de 31 años presenta desde hace varios meses astenia y malestar general. Además, ha presentado dolor articular en las manos y los codos. Su examen físico no aporta mayor información, por lo que se decido solicitar un hemograma y exámenes de orina, que muestra Hematocrito: 33%, hemoglobina 11 g/dl, VCM: 90 ft, plaquetas: 110.000 x mm3, blancos: 5.000 x mm3, sedimento de orina con hematuria de 60 GR por campo, con 20% de dismorfia. El diagnóstico más probable es:

a. Sarcoidosis
b. Lupus eritematoso sistémico
c. Púrpura trombocitopénico trombótico
d. Granulomatosis de Wegener
e. Poliangeítis microscópica

Respuesta correcta: b. Lupus eritematoso sistémico

Explicación: Es probablemente un lupus eritematoso sistémico (LES), ya que es una mujer joven con clínica sistémica (artralgias, astenia), más plaquetopenia y una glomerulonefritis (hematuria dismórfica). - La sarcoidosis se caracteriza por 5 síntomas: 1. Artritis, 2. Fiebre, 3. Eritema nodoso, 4. Adenopatías, 5. Afectación pulmonar (granulomas). - El PTT (púrpura trombocitopénico trombótico) es un cuadro agudo, con 1. Insuficiencia renal, 2. Plaquetopenia, 3. Anemia hemolítica microangiopática, 4. Afectación del sistema nervioso central (convulsiones o compromiso de conciencia) y periférico (parestesias) y 5. Fiebre. - La granulomatosis de Wegener (granulomatosis con poliangeítis) y la PAM (poliangeítis microscópica) son vasculitis de vaso pequeño, por lo que cursan con fiebre, artralgias, glomerulonefritis rápidamente progresiva, mononeuritis múltiple y compromiso pulmonar (alveolitis hemorrágica, entre otras). La PAM afecta a adultos mayores y el Wegener a personas más jóvenes y con más compromiso nasosinusal (sinusitis, otitis media, epistaxis). - Las plaquetas bajas orientan más a lupus que a vasculitis.

Fuente: Reumatología, cuestionario 6.1, P1

8. Una paciente de 46 años consulta por artralgias de manos, asociada a artritis de algunas articulaciones interfalángicas. Se solicitan exámenes que destacan ANA(+), ANCA(-), FR(-), AntiDNA(-), AntiRNP(+). No presenta otros síntomas y su hemograma y pruebas de función renal son normales. El diagnóstico más probable es:

a. Enfermedad mixta del tejido conectivo
b. Artritis reumatoide
c. Lupus eritematoso sistémico
d. Artrosis
e. Esclerodermia

Respuesta correcta: a. Enfermedad mixta del tejido conectivo

Explicación: Es una EMTC (enfermedad mixta del tejido conectivo) clásica: artritis, sin compromiso renal ni del SNC, más anticuerpos antirribonucleoproteína (antiRNP) positivos. Recordar que los anticuerpos antiRNP son un tipo de anticuerpos antinucleares (ANA). - La AR es FR (+) o anti-CCP(+), en un 80% de los casos. Los ANA suelen estar negativos, aunque, al igual que en los pacientes sanos, pueden estar positivos en un porcentaje de casos, por lo que manda es la clínica. Sin embargo, en este caso, la presencia de antiRNP y la clínica mostrada son clásicas de la EMTC. - El LES tiene ANA(+), pero además clínica adicional (fotosensibilidad, mariposa lúpica, afectación renal, hematológica, y un largo etcétera) y los anticuerpos clásicos son los anti-DNA2h(+) y los anti-Sm. - La esclerodermia tiene anticuerpos anti-Scl70 o los anticentrómero / antinucléolo y una presentación distinta, con fenómeno de Raynaud, esclerodactilia, calcinosis, alteraciones esofágicas (disfagia ilógica y pirosis).

Fuente: Reumatología, cuestionario 6.1, P4

9. ¿Cuál es la sospecha clínica frente a una paciente con eritema facial y úlceras orales?

a. Enfermedad de Behcet
b. Síndrome de Reiter
c. Lupus cutáneo subagudo
d. Lupus eritematoso sistémico
e. Dermatomiositis

Respuesta correcta: d. Lupus eritematoso sistémico

Explicación: El lupus tiene el eritema malar (mariposa lúpica) y úlceras orales indoloras. - La enfermedad de Behcent tiene úlceras genitales y orales dolorosas, más artritis y vasculitis secundaria con afectación nerviosa, tanto del SNP, como de SNC e incluso con afectación renal. Además, se caracteriza por el fenómeno de Patergia (pústula con SF). No tiene marcadores específicos. - El síndrome de Reiter es un tipo de artritis reactiva, que se caracteriza por la triada de artritis, uretritis y ojo rojo. Los microorganismos aceptados como causales de artritis reactiva son Chlamydia trachomatis, Chlamydia pneumoniae, Clostridioides difficile, Yersinia, Salmonella, Shigella y Campylobacter. El tratamiento suelen ser AINEs y, si no responde, corticoides orales o intraarticulares (más caros de administrar, pero con menos efectos adversos).

Fuente: Reumatología, cuestionario 6.2, P4

10. Mujer de 34 años con antecedentes de esplenectomía por púrpura trombocitopénico inmune crónico de difícil manejo hace 10 años, ha tenido 3 abortos y una trombosis venosa profunda. Desde hace un mes presenta un cuadro de artralgias generalizadas, astenia, adenopatías y fiebre. ¿Cuál de las siguientes pruebas de laboratorio cree de mayor utilidad para llegar al diagnóstico?:

a. Factor reumatoide y anticuerpos antinucleares (ANA).
b. Anticuerpos antinucleares (ANA) y anticardiolipina.
c. Factor reumatoide y anticuerpo enfermedad de Lyme.
d. Anticuerpo anti-ADN nativo y anti-Ro (SSA).
e. Anticuerpos anticitoplasma del neutrófilo (ANCAs) y antihistonas.

Respuesta correcta: b. Anticuerpos antinucleares (ANA) y anticardiolipina.

Explicación: Clínicamente sugiere un LES (mujer joven, con plaquetopenia, artralgias, fiebre, adenopatías), complicado con un síndrome antifosfolípidos (trombosis venosa profunda y abortos). Se deben pedir muchos exámenes, pero entre ellos, se incluyen los ANA (por el LES, al que además, hay que pedir exámenes generales, anticuerpos anti-DNA2h y Anti-Sm, o bien, el perfil ENA completo) y los anticardiolipina (por el SAF, al que además se le piden los anticuerpos antifosfolípidos, el VDRL que resulta falso positivo y el TTPA que se alarga).

Fuente: Reumatología, cuestionario 6.2, P16

11. ¿Cuál de las siguientes opciones NO es un criterio de lupus eritematoso sistémico?

a. Fotosensibilidad
b. Presencia de anticuerpos antinucleares
c. Trombocitosis
d. Psicosis
e. Derrame pericárdico

Respuesta correcta: c. Trombocitosis

Explicación: El lupus produce trombocitopenia, es decir, lo contrario a la trombocitosis. Los demás son criterios de lupus, aunque estos varían mucho según la fuente que se estudie (fotosensibilidad, rash malar, rash discoide, alopecia difusa; ANA, C3 o C4 bajo, Anti-DNA, Anti-Sm; trombopenia, linfopenia, leucopenia, anemia hemolítica; hematuria, proteinuria, falla renal, biopsia renal con glomerulonefritis lúpica; serositis: pericarditis, derrame pleural; artritis; úlceras orales, úlceras nasales; afectación del SNC: convulsiones, psicosis, meningitis aséptica; elevación de PCR / VHS, adenopatías, síntomas constitucionales: fiebre, baja de peso, sudoración nocturna, etc.). Lo importante es saber que el LES se presenta de muchas formas y ser capaz de identificar los distintos cuadros que lo sugieren. Reumatología

Fuente: Reumatología, cuestionario 6.2, P20

12. Una paciente de 18 años consulta por malestar general y aparición de lesiones eritematosas en la cara. Al examen físico se aprecian pápulas sobre las mejillas y el dorso nasal, con una base macular eritematosa. Además, está hipertensa y en sus exámenes destaca creatinina de 2,5 mg/dl. El diagnóstico más probable es:

a. Enfermedad de Wegener
b. Dermatomiositis
c. Lupus eritematoso sistémico
d. Síndrome hepatorrenal
e. Estenosis mitral congénita

Respuesta correcta: c. Lupus eritematoso sistémico

Explicación: Es probablemente un lupus eritematoso sistémico (LES), ya que es una mujer joven con la mariposa lúpica (rash malar) y afectación renal (elevación de la creatinina). - La granulomatosis de Wegener es una vasculitis de vaso pequeño, por lo que cursa con fiebre, artralgias, glomerulonefritis rápidamente progresiva, mononeuritis múltiple y compromiso pulmonar (alveolitis hemorrágica), aunque suele iniciar como rinosinusitus crónica. - La dermatomiositis presenta debilidad y mialgias, más compromiso cutáneo (rash heliotropo, Gottron y rash en manto). - El síndrome hepatorrenal es una insuficiencia renal aguda grave, en relación a un daño hepático crónico avanzado, con hipertensión portal. - La estenosis mitral congénita puede tener las chapetas mitrálicas en las mejillas, pero tiene clínica de insuficiencia cardíaca, soplo diastólico, etc.

Fuente: Reumatología, cuestionario 6.3, P2

13. Los anticuerpos AntiDNA de 1 hebra, son marcadores de:

a. Lupus discoide
b. Lupus eritematosos sistémico
c. Lupus por drogas
d. Enfermedad mixta del tejido conectivo
e. Esclerodermia

Respuesta correcta: c. Lupus por drogas

Explicación: Son marcadores del lupus por drogas (Anti-histona y anti-DNA 1 hebra). Los demás: Lupus discoide: anti-Ro y anti-La. Lupus eritematosos sistémico: anti-DNA 2 hebras y anti-Sm. Enfermedad mixta del tejido conectivo: anti-RNP (ribonucleoproteína). Esclerodermia: anti-Scl70, anticentrómero, antinucleólo.

Fuente: Reumatología, cuestionario 6.3, P3

14. Una mujer de 27 años, cursando embarazo de 12 semanas acude a su primer control médico, en el que refiere artralgias de manos, de larga evolución, pero que han aumentado considerablemente en el último tiempo. Al examen físico tiene FC: 80x', PA: 150/100 mmHg, se aprecia aumento de volumen, derrame articular y eritema en relación a las articulaciones interfalángicas proximales y metacarpofalángicas y se palpan adenopatías cervicales. Además, tiene edema de extremidades inferiores y proteinuria cualitativa ++. El diagnóstico más probable es:

a. Enfermedad de Still
b. Artritis reumatoide
c. Preclamsia
d. Lupus eritematoso sistémico
e. Síndrome antifosfolípidos

Respuesta correcta: d. Lupus eritematoso sistémico

Explicación: Tiene un LES clásico, con la afectación renal y articular. Suele empeorar con el embarazo, a diferencia de otras patologías autoinmunes. El síndrome antifosfolípidos también empeora en el embarazo y se asocia a LES, pero su clínica son trombosis (es una trombofilia adquirida) y malos resultados obstétricos (abortos, partos prematuros y preclamsia). Sus exámenes muestran alargamiento del TTPA (anticoagulante lúpico) y falsa positividad del VDRL.

Fuente: Reumatología, cuestionario 6.4, P2

Esclerodermia y fenómeno de Raynaud (5)

15. El fenómeno de Raynaud es característico de la siguiente patología:

a. Esclerodermia
b. Dermatomiositis
c. Síndrome de Sjörgren
d. Artritis reumatoide
e. Artritis psoriática

Respuesta correcta: a. Esclerodermia

Explicación: El fenómeno de Raynaud, el 80% de las veces es de tipo primario y benigno (suele empezar entre los 15 y 30 años, no tiene otros síntomas y es ANA-negativo). El 20% restante es secundario a enfermedades del tejido conectivo, en especial esclerodermia (la R de CREST, equivale a Raynaud), además del lupus.

Fuente: Reumatología, cuestionario 6.1, P13

16. Una paciente de 42 años consulta por un cuadro de 6 años de evolución de signo de Raynaud en las manos, acompañado de aparición de úlceras en las yemas de los dedos. Además, ha presentado problemas para tragar, que afecta tanto a sólidos, como a líquidos. En el último tiempo se ha agregado hipertensión arterial, que no tenía. Al examen físico está hipertensa y se aprecia eritema y edema de la piel de los dedos, la que se observa tirante y atrófica. Algo similar ocurre en la cara. El diagnóstico más probable es:

a. Lupus sistémico
b. Lupus discoide
c. Dermatomiositis
d. Enfermedad mixta del tejido conectivo
e. Esclerodermia

Respuesta correcta: e. Esclerodermia

Explicación: Tiene la clínica clásica de una esclerodermia tipo CREST (Calcinosis de los dedos, Raynaud, Esófago: disfagia ilógica y pirosis, Sclerodactilia y Telangiectasias). También tiene la complicación clásica: hipertensión pulmonar, de mal pronóstico. - El lupus discoide se presenta como placas eritematosas descamativas, en zonas expuestas a la luz, que luego dejan cicatrices. - La dermatomiositis presenta debilidad y mialgias, más compromiso cutáneo (rash heliotropo, Gottron y rash en manto).

Fuente: Reumatología, cuestionario 6.2, P1

17. ¿Cuál es la causa más frecuente de muerte en los pacientes con esclerodermia sistémica difusa?

a. Hipertensión pulmonar
b. Insuficiencia cardiaca
c. Cáncer
d. Fibrosis pulmonar
e. Accidente vascular encefálico

Respuesta correcta: d. Fibrosis pulmonar

Explicación: La esclerodermia se clasifica en difusa (mueren por fibrosis pulmonar) y en limitada o CREST (mueren de hipertensión pulmonar).

Fuente: Reumatología, cuestionario 6.2, P15

18. Una paciente de 40 años consulta por disfagia, asociada a signo de Raynaud intenso y recurrente. El diagnóstico más probable es:

a. Acalasia esogáfica
b. Dermatomiositis
c. Cáncer de esófago
d. Esófago de Barret
e. Esclerodermia Reumatología

Respuesta correcta: e. Esclerodermia Reumatología

Explicación: Tiene la clínica clásica de una esclerodermia tipo CREST (Calcinosis de los dedos, Raynaud, Esófago: disfagia ilógica, Sclerodactilia y Telangiectasias). En este caso, solo tiene el fenómeno de Raynaud y el compromiso esofágico. La acalasia también tiene disfagia ilógica (porque también es un trastorno motor del esófago), pero no tiene los demás síntomas del CREST. El cáncer de esófago tiene una disfagia lógica (ya que afecta más a los sólidos que a los líquidos y va aumentando con el tiempo), sin Raynaud. El esófago de Barret es una complicación del reflujo gastroesofágico, que se caracteriza por metaplasia intestinal de la mucosa esofágica y tiene riesgo de evolucionar a cáncer, pero es completamente asintomático. Reumatología

Fuente: Reumatología, cuestionario 6.3, P10

19. Una mujer de 25 años consulta por astenia, disnea y alteraciones en los dedos. Refiere que sus dedos se ponen blancos en algunas oportunidades y que la piel que los cubre se ha adelgazado. Al preguntar dirigidamente, también tiene dificultades para tragar, asociadas a pirosis. ¿Qué marcador es el más sugerente de esta patología?

a. Anti-Sm
b. Anticentrómero
c. HLA B27
d. Anti-Jo1
e. Anti-RNP

Respuesta correcta: b. Anticentrómero

Explicación: Parece un CREST o esclerodermia sistémica limitada, por lo que su marcador son los anticuerpos anticentrómero.

Fuente: Reumatología, cuestionario 6.4, P3

Miopatías inflamatorias (3)

20. Una paciente de 60 años consulta por un cuadro de mialgias y debilidad de predominio proximal, asociada a aparición de lesiones en la piel, localizadas principalmente en los párpados superiores, donde se aprecia eritema. La patología descrita suele estar asociada a otra enfermedad. Esta última enfermedad es:

a. Cáncer
b. Diabetes
c. Síndrome de Sjörgren
d. Enfermedad inflamatoria intestinal
e. Enfermedad celiaca

Respuesta correcta: a. Cáncer

Explicación: Se describe una dermatomiositis, con la afectación muscular (mialgias y debilidad proximal) y cutánea, en este caso con el rash heliotropo (afectación de párpados). Si bien la dermatomiositis es una enfermedad autoinmune, con mucha frecuencia se presenta como un síndrome paraneoplásico, por lo que además de tratarla con corticoides, se debe iniciar el estudio en busca de un cáncer.

Fuente: Reumatología, cuestionario 6.1, P7

21. Los anticuerpos anti-Jo1 son un marcador de:

a. Dematomiositis
b. Lupus por drogas
c. Esclerodermia
d. Enfermedad de Sjörgren
e. Panarteritis nodosa

Respuesta correcta: a. Dematomiositis

Explicación: La dermatomiositis suele tener como marcador más frecuente la CK elevada. Sin embargo, como todas las enfermedades del tejido conectivo, es ANA (+) y en específico presenta los anticuerpos anti-Jo1, anti-Mi2, anti-SRP, más una larga lista de otros anticuerpos menos conocidos. Los anti-Jo1 o antisintetasa son los más importantes, por asociarse al síndrome antisintetasa (dermatomiositis más fibrosis pulmonar). Como cultura general, si están presentes anticuerpos propios de otras enfermedades del tejido conectivo (ej. anti-RNP, Anti-Ro, Anti-La, etc.) se debe sospechar una miositis secundaria. El tratamiento consiste en corticoides e inmunomoduladores ahorradores de corticoides (azatioprina, metotrexato o rituximab, cada vez más usado en las enfermedades del tejido conectivo y vasculitis de vaso pequeño) y, además, se debe buscar activamente la presencia de cáncer, ya que la dermatomiositis suele ser paraneoplásica.

Fuente: Reumatología, cuestionario 6.2, P5

22. Una paciente presenta mialgias, debilidad muscular, de predominio proximal y eritema de los párpados superiores y sobre los hombros. ¿Qué marcador suele estar elevado?

a. Anticuerpos anti-nucléolo
b. Anticuerpos anti-centrómero
c. Anticuerpos anti-RNP
d. Anticuerpos anti-Ro
e. Anticuerpos anti-Jo1

Respuesta correcta: e. Anticuerpos anti-Jo1

Explicación: Tiene una dermatomiosistis clásica: mialgias y debilidad muscular de predominio proximal, más compromiso cutáneo (en este caso con el rash "heliotropo", en los párpados y el rash "en manto" en los hombros). Suele tener como marcador más frecuente la CK elevada. Sin embargo, como todas las enfermedades del tejido conectivo, es ANA (+) y en específico presenta los anticuerpos anti-Jo1, anti-Mi2 y anti-SRP. - Los anti-Jo1 o antisintetasa son los más importantes, por asociarse al síndrome antisintetasa (dermatomiositis más fibrosis pulmonar). De los demás: - Anticuerpos anti-nucléolo: esclerodermia. - Anticuerpos anti-centrómero: esclerodermia, en específico CREST. - Anticuerpos anti-RNP: enfermedad mixta del tejido conectivo (EMTC). - Anticuerpos anti-Ro: Junto con el Anti-La están en Sd. Sjögren, lupus discoide y bloqueo AV congénito.

Fuente: Reumatología, cuestionario 6.3, P6

Vasculitis (7)

23. Una mujer de 18 años consulta por dolor en la extremidad superior derecha, que aparece luego de algunos minutos de realizar actividades con esa extremidad y que cede con el reposo. Además, refiere que ha presentado fiebre intermitente y astenia. Al examen físico llama la atención que presenta ausencia de pulso en la extremidad afectada, mientras que en la otra extremidad sí se palpa el pulso, pero este es muy débil. El diagnóstico más probable es:

a. Enfermedad de Behcet
b. Púrpura fulminas
c. Arteritis de células gigantes
d. Síndrome del opérculo torácico
e. Vasculitis de Takayasu

Respuesta correcta: e. Vasculitis de Takayasu

Explicación: Es una vasculitis de Takayasu clásica: mujer joven (al igual que el lupus, 80-90% son mujeres) con clínica sistémica (fiebre, mialgias, artralgias; también suele haber sudoración nocturna y baja de peso) más síntomas de obstrucción de las grandes arterias (en este caso claudicación intermitente de las extremidades superiores y disminución de los pulsos radiales: también se llama la "enfermedad sin pulso"). Muchas veces se sospechan otras causas y la afectación arterial aparece en imágenes. - El diagnóstico suele hacerse con angioTAC o angioRMN (más cara, pero no irradia ni usa contraste), más el cuadro clínico. No hay marcadores específicos, aunque puede ser ANCA(+) en un bajo porcentaje. Por regla general eleva la PCR y VHS, pero son marcadores de inflamación muy inespecíficos. - El tratamiento son los corticoides orales (prednisona), aunque en los brotes se pueden usar EV y también se suelen agregar "ahorradores de corticoides": metotrexato, azatioprina, micofenolato, leflunomide (Las mismas DMARs). La cirugía vascular suele usarse para los casos con obstrucción arterial, pero idealmente se debe hacer una vez controlada la inflamación. - La enfermedad de Behcet es rara se caracteriza por úlceras dolorosas y recurrentes en boca y genitales, más fenómeno de Patergia (pústula al inyectar suero fisiológico), uveítis (con mucha frecuencia), artritis y vasculitis secundaria, que puede afectar grandes y pequeños vasos, con afectación secundaria del sistema nervioso central y periférico e incluso renal. No tiene marcadores específicos y el diagnóstico es clínico. Los casos leves se tratan con corticoides tópicos (ej. en lesiones genitales, bucales y uveítis anterior). Los casos graves se tratan con inmunomoduladores y finalmente biológicos.

Fuente: Reumatología, cuestionario 6.1, P2

24. Una niña presenta un cuadro de hematuria, asociada a aparición de lesiones cutáneas eritematosas, como se muestra en la imagen. El diagnóstico más probable es:



a. Púrpura de Schonlein Henoch
b. Artritis juvenil idiopática
c. Púrpura trombocitopénico inmune agudo
d. Lupus infantil
e. Dermatomiositis infantil

Respuesta correcta: a. Púrpura de Schonlein Henoch

Explicación: Es una púrpura de Schonlein Henoch clásica, tanto por las lesiones purpúricas de EEII, como por la hematuria. El cuadro completo, incluye el púrpura palpable, hematuria, artritis y compromiso abdominal (dolor, hematoquecia). El diagnóstico es clínico. El tratamiento depende de la severidad. Si está bien, simplemente se observa y se deja hidratación oral, sin ningún medicamente. Si tiene dolor articular o abdominal, se pueden usar AINEs o paracetamol. Los corticoides solo están indicados en casos de: 1. artritis muy dolorosa o que no responde a AINEs. 2. dolor abdominal severo o complicaciones (ej. perforación). 3. afectación renal grave (ej. GNRP, IRA, proteinuria >1 g/día, síndrome nefrótico)

Fuente: Reumatología, cuestionario 6.1, P5

25. Un paciente de 66 años consulta por astenia y cefalea. Refiere además que en algunas ocasiones debe descansar mientras mastica, ya que presenta dolor de los músculos masticatorios. Le sucede algo similar

al usar las extremidades superiores, ya que "se le cansan los hombros". Al examen presenta dolor a la palpación del cuero cabelludo. En sus exámenes destaca un hemograma con hematocrito: 33%, VCM: 90, HCM: 32, hemoglobina: 11, blancos: 6.900, con recuento diferencial normal, plaquetas: 342.000, VHS: 96. El diagnóstico más probable es:

a. Lupus eritematoso sistémico
b. Poliangeítis microscópica
c. Arteritis de células gigantes
d. Granulomatosis de Wegener
e. Panarteritis nodosa

Respuesta correcta: c. Arteritis de células gigantes

Explicación: Tiene una clínica clásica de arteritis de la temporal o de células gigantes (astenia, cefalea, claudicación mandibular, polimialgia reumática [dolor y debilidad de hombros] y dolor del cuero cabelludo). Además, tiene la VHS muy elevada, que es el único marcador característico (aunque muy inespecífico). El diagnóstico se realiza con la biopsia de la arteria temporal (en realidad se afectan muchas arterias, pero la arteria temporal superficial no es un vaso importante, a diferencia de las arterias cerebrales, por ejemplo). El tratamiento es con corticoides orales en dosis altas (ej. prednisona 60 mg/d). Si tiene amaurosis (fugax o establecida), se pueden dan por vía endovenosa (ej. metilprednisolona 1g EV x 3 días, seguido de prednisona). Los demás fármacos tienen poca utilidad, aunque podría ayudar a "ahorrar" corticoides el tocilizumab (anticuerpo contra el recepto de la IL-6).

Fuente: Reumatología, cuestionario 6.1, P16

26. Un niño consulta por fiebre de 7 días de evolución, asociado a un rash papuloeritematoso generalizado. En el examen se observa eritema e inyección conjuntival. Los labios y la lengua están enrojecidos y aumentados de volumen. Se palpan 2 adenopatías cervicales anteriores, la mayor de ellas de 2,5 cm. Además se constata edema, eritema y fina descamación en ambos pies. El tratamiento de la patología descrita es:

a. Corticoides orales
b. Corticoides endovenosos
c. Corticoides endovenosos + inmunosupresores
d. Aspirina + Inmunoglobulina G endovenosa
e. Plasmaféresis

Respuesta correcta: d. Aspirina + Inmunoglobulina G endovenosa

Explicación: Es un cuadro de Kawasaki clásico (1. fiebre de 5 días o más: siempre debe estar; rash, 2. ojo rojo, 3. boca roja, 4. adenopatías cervicales y 5. compromiso de manos y pies). El diagnóstico es clínico y el tratamiento es inmunoglobulina G en altas dosis por vía endovenosa (lo más importante) más aspirina (y, en casos seleccionados, corticoides). Sin tratamiento, algunos casos evolucionan a daño coronario. Con tratamiento, casi siempre resuelve de manera completa sin secuelas. La importancia de esta enfermedad es que el diagnóstico es clínico y las complicaciones pueden ser graves y evitables. La ecografía coronaria es un examen que determina el pronóstico (si hay aneurismas coronarias es de mal pronóstico; se suele repetir cada 2 a 4 semanas). La ecografía también tiene una función diagnóstica, en los los casos de Kawasaki incompleto (ej. 2 o 3 criterios, sin otra causa evidente).

Fuente: Reumatología, cuestionario 6.1, P18

27. Un paciente de 68 años consulta por malestar general, asociado a hematuria y oliguria. Al examen físico se aprecia febril a 38,5°C, se aprecia edema de EEII y su presión arterial es de 190/110 mmHg.

Además, destacan lesiones eritematosas cutáneas, en las extremidades inferiores y zonas del tronco. Se solicitan exámenes generales, que muestran un hemograma normal, con creatinina de 5,8 mg/dl y sedimento de orina con hematuria, de tipo dismórfico. El diagnóstico de sospecha es:

a. Panarteritis nodosa
b. Lupus eritematoso sistémico
c. Púrpura trombocitopénico trombótico
d. Arteritis de la temporal
e. Poliangeítis microscópica

Respuesta correcta: e. Poliangeítis microscópica

Explicación: Es un adulto mayor con una glomerulonefritis (hematuria dismórfica) de tipo rápidamente progresiva (porque se asocia a una insuficiencia renal aguda grave), más un síndrome nefrítico (edema, HTA y hematuria). Por la edad y lo agresivo del cuadro, lo más probable es que sea una PAM (poliangeítis microscópica). Se debe solicitar ANCA (suele salir positivo en patrón perinuclear: ANCA-p, cuyo equivalente en un elisa son los anticuerpos anti-mpo (mieloperoxidasa). Su tratamiento es con corticoides endovenosos e inmunosupresores (actualmente se prefiere el rituximab: anticuerpos anti-CD30, proteína del linfocito B, si está disponible, aunque sigue siendo útil la antigua ciclofosfamida). Es muy grave. A nivel renal suele hacer GNRP con patrón crescéntico y pauciinmune. - La PAN (panarteritis nodosa) no produce glomerulonefritis, porque es una vasculitis de vaso mediano. - La arteritis de la temporal tampoco, porque es una vasculitis de vaso grande. - El LES podría tener el mismo cuadro, pero afecta a mujeres jóvenes y no a adultos mayores. - El PTT puede tener un cuadro similar, pero le falta la anemia hemolítica y la trombopenia característica; además que la insuficiencia renal no necesariamente tiene hematuria asociada (frecuentemente el PTT sí la tiene).

Fuente: Reumatología, cuestionario 6.2, P6

28. Los anticuerpos anticitoplasma de neutrófilos son característicos de:

a. Vasculitis primarias
b. Enfermedades del tejido conectivo
c. Pelviespondiloartropatías
d. Artritis reumatoide
e. Polimialgia reumática y arteritis de la temporal

Respuesta correcta: a. Vasculitis primarias

Explicación: Los ANCA son característicos de las vasculitis primarias. ANCA en patrón C es característico de la granulomatosis de Wegener (equivale a los anti-pr3) y ANCA en patrón P es característico de las demás vasculitis (equivale a los anti-mpo). Algunas vasculitis son ANCA negativa, como la arteritis de la temporal (o de células gigantes), la vasculitis por IgA (o púrpura de Schönlein Henoch), la arteritis de Takayasu y la poliarteritis nodosa (aunque estas dos últimas sí pueden ser ANCA-p positiva en un porcentaje de los casos. Eso sí, la evidencia más reciente sugiere que podría tratarse de casos de PAM con afectación de grandes vasos, en especial porque las distintas vasculitis pueden superponerse en su presentación clínica y su fisiopatología).

Fuente: Reumatología, cuestionario 6.2, P10

29. Una paciente de 40 años presenta un cuadro de malestar general, fiebre y oliguria. Al examen físico presenta edema de las extremidades inferiores. Se solicitan exámenes generales que muestran creatinina de 6,5 mg/dl, hematuria dismórfica y normalidad de las pruebas hepáticas y el hemograma. Se solicitan

anticuerpos que muestran ANA(-), ANCA(+) en patrón citoplasmático y perfil ENA negativo. El diagnóstico más probable es:

a. Lupus sistémico
b. Poliangeítis microscópica
c. Granulomatosis de Wegener
d. Síndrome de Churg Strauss
e. Síndrome de Good Pasture

Respuesta correcta: c. Granulomatosis de Wegener

Explicación: Tiene clínica de una vasculitis de vaso pequeño: fiebre, malestar, glomerulonefritis rápidamente progresiva (hematuria dismórfica más falla renal aguda grave), además de ser ANCA positivo. En este caso, por ser ANCA-C (citoplasmático) es una granulomatosis de Wegener, ya que es la única patología con dicho marcador. Si la historia hubiese sido igual, pero con los ANA(+), en lugar de los ANCA, sería un lupus sistémico.. Si hubiese sido ANCA-P (perinuclear), probablemente sería una PAM (poliangeítis microscópica, aunque suele afectar a personas de mayor edad. También podría haber sido un Churg-Strauss, si viniera con asma severo. El síndrome de Good Pasture es una enfermedad por anticuerpos anti-membrana basal, que produce un síndrome riñón-pulmón (glomerulonefritis más alveolitis hemorrágica). Se puede dar aislado o junto a las vasculares de caso pequeño.

Fuente: Reumatología, cuestionario 6.3, P8

Espondiloartropatías (10)

30. ¿Cuál de las siguientes es una complicación extraarticular de la espondilitis anquilosante?

a. Glomerulonefritis
b. Meningitis aséptica
c. Mononeuriris múltiple
d. Eritema nodoso
e. Derrame pleural

Respuesta correcta: d. Eritema nodoso

Explicación: La espondilitis anquilosante (EAA) se caracteriza por 1. Uveítis (30%), 2. Eritema nodoso y pioderma gangrenoso, 3. Aortitis, 4. Fibrosis pulmonar. - La glomerulonefritis es complicación del lupus y las vasculitis. - La meningitis aséptica es complicación del lupus. - La mononeuritis múltiple se ve en las vasculitis primarias (PAM, Wegener, PAN) y también en las secundarias (ej. AR, siendo muy rara en la EAA). - El derrame pleural es complicación de la AR y del lupus (ambos son exudados mononucleares con ADA alta, es decir, se parecen al derrame por TBC).

Fuente: Reumatología, cuestionario 6.1, P8

31. Un paciente de 27 años presenta un cuadro de dolor lumbar crónico, mayor en reposo, asociado a rigidez matinal. En alguna ocasión presentó artritis de la rodilla derecha. Se solicita radiografía de articulaciones sacroilíacas que demuestra signos de sacroileítis bilateral y de algún grado de calcificación de los ligamentos longitudinales anterior y posterior. El tratamiento de elección de la patología descrita es:

a. Corticoesteroides y kinesioterapia
b. Metotrexato y ciclosporina
c. Antiinflamatorios no esteroidales y ejercicios

d. Metotrexato y ejercicios
e. Ciclosfosfamida y corticoides

Respuesta correcta: c. Antiinflamatorios no esteroidales y ejercicios

Explicación: Es una espondilitis anquilosante clásica, confirmada con la radiografía (suele ser el examen de primera línea, aunque el más sensible es la RMN de sacroilíacas). Su tratamiento es con AINEs y ejercicios. Suele responder muy bien a los AINEs. Los AINEs más usados son: el naproxeno, ibuprofeno, diclofenaco, indometacina y celecoxib. Sin embargo, cualquiera puede ser efectivo. En este caso, la presencia de la radiografía "en caña de bambú", sugiere que lleva muchos años con la patología, ya que en los estadios iniciales, la EAA puede tener una radiografía normal o solo mostrar afectación de las articulaciones sacroilíacas.

Fuente: Reumatología, cuestionario 6.1, P9

32. La artritis psoriática se manifiesta con mayor frecuencia como:

a. Una monoartritis aguda migratoria y recidivante
b. Una oligoartritis que compromete las articulaciones cuya piel circundante presenta placas psoriáticas
c. Una oligoartritis asimétrica y migratoria de grandes y pequeñas articulaciones, asociada a dactilitis
d. Una poliartritis simétrica distal, de pequeñas y grandes articulaciones, asociadas a rigidez matinal de más de 30 minutos de duración
e. Una poliartritis de pequeñas articulaciones, asimétrica, asociada a compromiso renal

Respuesta correcta: c. Una oligoartritis asimétrica y migratoria de grandes y pequeñas articulaciones, asociada a dactilitis

Explicación: La artritis psoriática, al igual que las demás pelviespondiloartropatías (PEA), se suele presentar como una oligoartritis migratoria de pequeñas y grandes articulaciones. De hecho, la frase "oligoartritis asimétrica" es algo que sugiere mucho una PEA. Además, es frecuente la dactilitis o "dedos en salchicha" (se puede ver en todas las PEA, pero es más frecuente en la artritis psoriática). Finalmente suele tener psoriasis cutánea o ungueal con mucha frecuencia. La A sugiere una artritis por cristales (ej. condrocalcinosis). La B no existe. La D es una AR. La E podría ser un LES.

Fuente: Reumatología, cuestionario 6.1, P10

33. Un paciente de 20 años presenta dolor lumbar, que lo despierta en la noche y que es muy intenso en la mañana, pero que va cediendo, a medida que realiza actividad física. Además presenta dolor en los talones y algunas éntesis. Al examen físico se aprecia limitación a la flexión de la columna lumbar. Ante la sospecha diagnóstica, ¿qué marcador estará positivo con mayor probabilidad?

a. Factor reumatoide
b. Creatinfosfokinasa
c. Anticuerpos antinucleares
d. Anticuerpos antinucleolares
e. Ninguno

Respuesta correcta: e. Ninguno

Explicación: Es una espondilitis anquilosante (lumbago inflamatorio, rigidez lumbar y entesitis), que se caracteriza por ser seronegativa, es decir, por no tener ningún anticuerpo elevado. Sin embargo, sí se asocia a la presencia del gen de histocompatibilidad HLA-B27. * Las entesitis (inflamación de la unión

entre un tendón y el hueso) suelen ser muy sugerentes de pelviespondiloartropatías, como la EAA y el lugar más frecuente es precisamente el talón, tanto en la inserción de la fascia plantar, como del tendón de Aquiles. Los parámetros inflamatorios suelen estar elevados (PCR y VHS). El diagnóstico suele complementarse con una radiografía de sacroilíacas (muestra sacroileítis y, en casos avanzados, la columna en "caña de bambú", con calcificación y anquilosis de los ligamentos paravertebrales). En los casos recientes, la radiografía puede estar normal y la RMN de sacroilíacas sería el examen con mayor rendimiento (se pide en casos en que la radiografía está normal, pero la sospecha es alta). - El FR es marcador de AR y Sd. De Sjögren. - La CK se eleva en polimiositis / dermatomiositis y también en la polimialgia reumática o otras causas de miositis. Los ANA son del LES y demás enfermedades del tejido conectivo. Los antinucleolares son de la esclerodermia.

Fuente: Reumatología, cuestionario 6.2, P9

34. ¿Cuál de las siguientes patologías es más frecuente en hombres que en mujeres?

a. Artrosis
b. Dermatomiositis
c. LES
d. Espondilitis anquilosante
e. Esclerodermia

Respuesta correcta: d. Espondilitis anquilosante

Explicación: La artrosis es casi igual de frecuente en ambos sexos. La dermatomiositis, LES y esclerodermia son más frecuentes en mujeres, como todas las enfermedades de tejido conectivo (ETC). La espondilitis anquilosante, en cambio, al igual que otras pelviespondilopatías, es más frecuente en hombres.

Fuente: Reumatología, cuestionario 6.2, P11

35. La asociación de oligoartritis asimétrica, dactilitis y placas cutáneas eritematosas y descamativas es propia de:

a. Artritis psoriática
b. Panarteritis nodosa
c. Crioglobulinemia
d. Dermatomiositis
e. Esclerodermia

Respuesta correcta: a. Artritis psoriática

Explicación: Es una artritis psoriática de libro, con las placas de psoriasis incluidas. - La PAN tiene mialgias, mononeuritis múltiple y angina mesentérica (se asocia a hepatitis B). Por ser una vasculitis de vaso mediano, suele diagnosticarse con angiografía mesentérica o biopsia de arterias mesentéricas. - La crioglobulinemia tiene una glomerulonefritis aguda, con complemento bajo y lesiones cutáneas en zonas que se enfrían (orejas, dedos, pies).

Fuente: Reumatología, cuestionario 6.2, P14

36. Un paciente de 45 años presenta un cuadro diarreico autolimitado. Diez días después inicia cuadro de dolor lumbar, artritis asimétrica de rodillas y manos, asociados a ojo rojo profundo y disuria. El diagnóstico más probable es:

a. Púrpura trombocitopénico trombótico
b. Síndrome de Reiter

c. Enfermedad de Behcet
d. Vasculitis de Wegener
e. Crioglobulinemia

Respuesta correcta: b. Síndrome de Reiter

Explicación: Es un síndrome de Reiter clásico: variante de la artritis reactiva, pero con ojo rojo (en este caso uveítis, por el ojo rojo profundo) y uretritis. En general son secundarios a diarreas por Campilobacter o Yersinia, aunque se han descrito por Shigella, Salmonella, Clostridium difficile y Chlamydia (tanto trachomatis como pneumoniae). Su diagnóstico es clínico. Su tratamiento son AINEs y, si no responde, corticoides orales o intraarticulares. Los antibióticos no suelen servir, ya que la infección pasó, con la única excepción de la portación de Chlamydia, que siempre conviene tratar con doxiciclina. - La A (PTT) se caracteriza por insuficiencia renal aguda, hemólisis, trombopenia, afectación del SNC (similar al síndrome hemolítico urémico), más fiebre. - La C (Behcet) tiene úlceras orales y genitales, dolorosas, más artritis y afectación del sistema nervioso periférico y central. - La D (Wegener) habitualmente tiene rinosinusitis crónica, con la clínica de las vasculitis de vaso pequeño (fiebre, rash, glomerulonefritis rápidamente progresiva y alveolitis hemorrágica).

Fuente: Reumatología, cuestionario 6.2, P17

37. Un paciente de 28 años presenta un cuadro de lumbago mayor en la mañana y artritis de la rodilla izquierda. Además, presenta una uveítis izquierda, que responde bien al tratamineto con corticoides en colirio. ¿Qué marcador estará elevado con mayor probabilidad?:

a. ANA
b. ANCA
c. Factor Reumatoide
d. Anticuerpos antitransglutaminasa
e. Ninguno

Respuesta correcta: e. Ninguno

Explicación: Es una espondilitis anquilosante (lumbago inflamatorio, artritis periférica y uveítis), que se caracteriza por ser seronegativa, es decir, por no tener ningún anticuerpo elevado. Sin embargo, sí se asocia a la presencia del gen de histocompatibilidad HLA-B27. Los ANA son del LES y demás enfermedades del tejido conectivo. Los ANCA son de las vasculitis primarias. El FR es marcador de AR y Sd. De Sjögren. Los anti-TGT son de la enfermedad celíaca.

Fuente: Reumatología, cuestionario 6.3, P4

38. Un paciente de 23 años consulta por dolor glúteo y lumbar, crónico, que aparece al despertar y que cede con los movimientos durante el día. Además, ha presentado dolor en los talones y rodillas. Se solicita una radiografía de columna, que resulta normal. ¿Qué examen es más adecuado para proseguir el estudio?:

a. Factor reumatoide y anticuerpos anticitrulina
b. Resonancia magnética nuclear de columna lumbosacra y articulaciones sacroilíacas
c. Anticuerpos antinucleares y antiDNA
d. Estudio de líquido sinovial
e. Hemograma y VHS

Respuesta correcta: b. Resonancia magnética nuclear de columna lumbosacra y articulaciones sacroilíacas

Explicación: La sospecha es una espondilitis anquilosante u otra pelviespondilopatía. El examen inicial sigue siendo la radiografía, pero el con mejor rendimiento es la RMN, por lo que debe pedirse tras una radiografía normal. Recordemos que el síndrome facetario también suele ser mayor en la mañana, pero se caracteriza por ser dolor de tipo mecánico. También podría ser útil el antígeno HLA-B27, que es un marcador, aunque tiene falsos positivos y negativos.

Fuente: Reumatología, cuestionario 6.4, P1

39. Un paciente de 23 años inicia dolor lumbar de 6 meses de evolución, mayor en las mañanas, asociado a rigidez que cede a medida que realiza actividad física. Al examen físico no es capaz de flectar la columna, llegando a tocar sólo las rodillas con las extremidades inferiores extendidas. Se solicitan exámenes, que muestran factor reumatoide negativo, anticuerpos antinucleares negativos, antígeno HLA-B27 positivo y radiografía de columna lumbosacra, que muestra signos de sacroileítis. La conducta más adecuada es:

a. Iniciar terapia biológica con inhibidores de TNF alfa
b. Educar, iniciar naproxeno y ejercicios
c. Solicitar RNM de columna lumbosacra
d. Iniciar metotrexato
e. Iniciar corticoides orales y reposo relativo

Respuesta correcta: b. Educar, iniciar naproxeno y ejercicios

Explicación: Tiene una espondilitis anquilosante clásica, cuyo tratamiento inicial son los AINES (cualquiera), más ejercicios de elongación y educación. En los casos que no responden, se inicia terapia biológica, por ejemplo, con infliximab (aunque existen actualmente múltiples fármacos biológicos útiles y más seguros como el etanercept y el adalimumab). Generalmente, no requiere de corticoides, drogas modificadoras de la AR (salvo en complicaciones extra articulares y otros casos seleccionados). Como ya tiene alteraciones en la radiografía y HLA-B27 positivo, no se requiere la resonancia magnética ni nigún otro examen.

Fuente: Reumatología, cuestionario 6.4, P6

Artritis por cristales (4)

40. Un paciente de 69 años presenta dolor muy intenso en la rodilla derecha, que inició hace pocas horas. Al examen físico se aprecia aumento de volumen y eritema de la rodilla derecha, con signos de derrame articular. Se solicita una radiografía, que se muestra a continuación. El diagnóstico más probable es:



a. Artrosis
b. Artritis séptica
c. Gota
d. Condrocalcinosis
e. Artritis reumatoide

Respuesta correcta: d. Condrocalcinosis

Explicación: Tiene una monoartritis aguda en el adulto mayor, cuya causa más frecuente es la condrocalcinosis, sin embargo, también puede ser una atritis séptica u otra causa, por lo que, habiendo signos de derrame articular, es prácticamente obligatorio solicitar una punción articular y estudio de líquido sinovial (la condrocalcinosis se verá con cristales con birrefringencia de elongación positiva en el microscopio con luz polarizada). La radiografía es correcto haberla solicitado (y es obligatorio como primer examen, cuando hay antecedente de trauma o sospecha de tumor, como causa de la monoartritis). En este caso, muestra calcificación de los meniscos y la condrocalcinosis se caracteriza por calcificar el cartílago articular ("condrocalcinosis" significa enfermedad por calcificación de los cartílagos). - El tratamiento en agudo actualmente ha cambiado y se recomienda la aspiración del derrame articular, más inyección de corticoides intraarticulares (ej. triamcinolona). La antigua opción de analgésicos intravenosos u orales sigue siendo una opción: generalmente AINEs (ej. naproxeno o ketorolaco) o colchicina (especialmente si lleva menos de 24 horas de dolor) o bien, prednisona en dosis bajas. - La profilaxis de recurrencias consiste en identificar una causa secundaria y tratarla (ej. hiperparatiroidismo primario). Si

no es una condrocalcinosis primaria, actualmente se recomienda la colchicina en dosis bajas como profilaxis, en los casos en que haya 3 o más crisis.

Fuente: Reumatología, cuestionario 6.1, P11

41. Paciente de 68 años presenta artritis de aguda de rodilla, la que se punciona, dando salida a un líquido inflamatorio con 10.000 células por mm3, con abundantes cristales compatibles con pirofosfato de calcio, sin visualización de bacterias. La conducta más adecuada es:

a. Indicar reposo e iniciar AINEs y colchicina
b. Indicar reposo, analgésicos y alopurinol
c. Indicar reposo, analgésicos y bifosfonatos
d. Indicar reposo, analgésicos, bifosfonatos y alopurinol
e. Indicar reposo, analgésicos y antibióticos

Respuesta correcta: a. Indicar reposo e iniciar AINEs y colchicina

Explicación: Tiene una condrocalcinosis confirmada. - El tratamiento en agudo actualmente ha cambiado y se recomienda la aspiración del derrame articular, más inyección de corticoides intraarticulares (ej. triamcinolona). La antigua opción de analgésicos intravenosos u orales sigue siendo una opción: generalmente AINEs (ej. naproxeno o ketorolaco) o colchicina (especialmente si lleva menos de 24 horas de dolor) o bien, prednisona en dosis bajas. - La profilaxis de recurrencias consiste en identificar una causa secundaria y tratarla (ej. hiperparatiroidismo primario). Si no es una condrocalcinosis primaria, actualmente se recomienda la colchicina en dosis bajas como profilaxis, en los casos en que haya 3 o más crisis. - Los bifosfonatos son el tratamiento de la osteoporosis.

Fuente: Reumatología, cuestionario 6.1, P20

42. Un paciente de 54 años está hospitalizado por un cuadro de podagra izquierda, que fue manejado exitosamente con AINEs endovenosos. Pocos meses antes había presentado el mismo cuadro, también en la primera articulación metatarsofalángica izquierda. Actualmente está en buenas condiciones y se ha decidido darlo de alta. Su uricemia plasmática es de 10,5 mg/dl. ¿Cuál es la conducta más adecuada para el manejo de este paciente?

a. Enviar a domicilio con hidroclorotiazida y aumento de la ingesta de agua
b. Enviar a domicilio con alopurinol e hidroclorotiazida oral, más dieta
c. Enviar a domicilio con dieta y aumento de la ingesta de agua
d. Enviar a domicilio con alopurinol, probenecid y furosemida
e. Enviar a domicilio con alopurinol oral e insistir en el cumplimiento de la dieta

Respuesta correcta: e. Enviar a domicilio con alopurinol oral e insistir en el cumplimiento de la dieta

Explicación: Tiene una gota comprobada, con 2 crisis en el último año, por lo que está indicado el tratamiento farmacológico, además de la dieta y cambio en el estilo de vida. - Si bien, se fija como indicaciones de terapia 1. la gota tofácea y 2. dos crisis en un año, la verdad es que no hay un corte estricto y es factible iniciar fármacos para normalizar en ácido úrico incluso con una sola crisis. Actualmente, la evidencia científica, recomienda iniciar con alopurinol en dosis bajas (100 mg/día), aumentándolas progresivamente, hasta alcanzar un ácido úrico normal (menor a 6 mg/dl idealmente y menor a 5 mg/dl en la gota tofácea). - A diferencia de lo que se creía antes, actualmente es aceptable iniciar el alopurinol durante la misma crisis, ya que no empeora la crisis (mito eliminado por la ciencia). Sin embargo, tampoco tiene mayor utilidad iniciarlo en la crisis ni menos aún suspenderlo, si es que ya se inició. Por tanto, sigue aplicando la frase "no cambie el alopurinol en la crisis de gota, sino después de resuelta". - Otros inhibidores de la xantino oxidasa, como el buxostat, se pueden usar, pero no son

mejores que el alopurinol (y son más caros). Los uricosúricos existen, pero, en la práctica no se usan, salvo en casos refractarios y de manejo de especialista. Existen tratamientos nuevos para casos muy seleccionados, pero son de manejo del reumatólogo. - Los diuréticos de asa (furosemida) y las tiazidas (HCTZ) están contraindicados, ya que elevan los niveles de ácido úrico y aumentan las crisis gotosas.

Fuente: Reumatología, cuestionario 6.2, P3

43. Un paciente de 56 años consulta por dolor muy intenso en el pie derecho. Refiere que el día anterior consumió alcohol en una fiesta y que despertó por el dolor a la mañana siguiente. No se golpeó y al examen se aprecia eritema y aumento de volumen en relación a la primera articulación metatarsofalángica derecha. El tratamiento más adecuado para la situación actual de este paciente es:

a. Indicar reposo e iniciar naproxeno oral.
b. Iniciar alopurinol oral
c. Iniciar bifosfonatos orales
d. Iniciar paracetamol y alopirinol orales
e. Iniciar metotrexato oral

Respuesta correcta: a. Indicar reposo e iniciar naproxeno oral.

Explicación: Parece una crisis de gota, ya que tiene una podagra (artritis aguda de la primera articulación metatarsofalángica). En agudo existen 3 formas aceptables de tratar, todas con evidencia científica robusta: 1. Corticoides orales, 2. AINES orales y 3. Colchicina oral. Lo habitual son los AINES, pero algunas recomendaciones internacionales prefieren los corticoides. El alopurinol solo se indica si ha habido 2 o más crisis en 1 año y se va aumentando la dosis hasta lograr la normalización del ácido úrico plasmático. - A diferencia de lo que se creía antes, actualmente es aceptable iniciar el alopurinol durante la misma crisis, ya que no empeora la crisis (mito eliminado por la ciencia). Sin embargo, tampoco tiene mayor utilidad iniciarlo en la crisis ni menos aún suspenderlo, si es que ya se inició. Por tanto, sigue aplicando la frase "no cambie el alopurinol en la crisis de gota, sino después de resuelta". La colchicina es especialmente buena en las primeras 24 horas de síntomas y, además, eventualmente puede usarse para prevenir nuevas crisis, ejemplo, en pacientes que no toleran el alopirinol o que no logran normalizar el ácido úrico (no siempre es fácil).

Fuente: Reumatología, cuestionario 6.3, P7

Artritis séptica y artritis en el niño (2)

44. Un niño de 3 años presenta cojera de 1 día de evolución, sin otros síntomas. La madre refiere que estuvo decaído y con rinorrea hace una semana. Al examen físico se aprecia en buenas condiciones, con leve dolor a la rotación externa de la cadera izquierda, sin otros hallazgos. El diagnóstico más probable es:

a. Artritis séptica
b. Displasia de cadera
c. Enfermedad de Perthes
d. Epifisiolisis de la cabeza femoral
e. Sinovitis transitoria

Respuesta correcta: e. Sinovitis transitoria

Explicación: Es una sinovitis transitoria clásica (niño pequeño con dolor en cadera o rodilla, sin mayor compromiso. El antecedente clásico es una infección viral una semana antes). - La artritis séptica tendría fiebre alta y signos inflamatorios evidentes. - La displasia de cadera es un cuadro crónico, que empeora con el tiempo (a medida que se desarrolla artrosis). - La enfermedad de Perthes afecta a niños entre 5 y

10 años (rango total: 2 a 13 años), con dolor en la cadera. Se asocia a talla baja y a antecedentes familiares. Suele tener una evolución más arrastrada e insidiosa. Algo importante es que estudios más recientes muestran que hay mucha superposición entre las edades de la sinovitis transitorias y la enfermedad de Legg Calvé Perthes (llamada actualmente osteonecrosis idiopática de la cabeza femoral), ya que ambas se presentan con cierta frecuencia entre los 3 y los 8 años (Perthes puede ser en mayores), por tanto, la principal diferencia entre ambas es el tiempo de evolución, ya que la sinovitis suele duran cerca de una semana (solo en pocos casos se alarga y se estudia), mientras que la enfermedad de Perthes suele ser más subaguda. Se diagnostica con la radiografía de caderas, aunque al inicio puede estar normal y ser necesaria una RMN. Se maneja ortopédicamente y, en casos graves, con cirugía. - La epifisiolisis de la cabeza femoral también produce dolor en la cadera, pero afecta a escolares grandes o adolescentes (12 a 15 años) y se asocia a obesidad. Se diagnostica con la radiografía (signo del "helado caído"). Se maneja con cirugía.

Fuente: Reumatología, cuestionario 6.1, P19

45. Paciente de 27 años consulta por dolor intenso en rodilla derecha, de 24 horas de evolución, progresivo y que se ha asociado a sensación febril. Al examen físico, tiene FC: 88x', PA: 120/80 mmHg, Tº: 38ºC y en el examen segmentario destaca eritema, aumento de volumen y de temperatura local a nivel de la articulación descrita. Se realiza punción articular, que demuestra presencia de escasos cristales y cocáceas gram negativos. El tratamiento más adecuado es:

a. Drenaje quirúrgico + vancomicina endovenosa
b. Drenaje quirúrgico + ceftriaxona endovenosa
c. Antiinflamatorios no esteroidales y reposo
d. Alopurinol oral más antiinflamatorios
e. Ceftriaxona intramuscular

Respuesta correcta: b. Drenaje quirúrgico + ceftriaxona endovenosa

Explicación: Tiene una artritis séptica por gonococo. Se trata con ceftriaxona endovenosa, más el drenaje quirúrgico (idealmente por artroscopía). Cuando son por Staphilococcus aureus, si bien el tratamiento inicial históricamente ha sido la cloxacilina u otro betalactámico con acción antiestafilocócica, dado el aumento de la prevalencia de estafilococos resistentes, en muchos lugares se prefiere iniciar con vancomicina y cambiar el antibiótico, una vez que se tenga el estudio de susceptibilidad.

Fuente: Reumatología, cuestionario 6.4, P5

Artrosis y reumatismo de partes blandas (5)

46. El mejor examen para iniciar el estudio en un paciente en que se sospecha un síndrome de manguito rotador es:

a. Radiografía
b. Ecografía
c. Resonancia magnética nuclear
d. TAC
e. CK

Respuesta correcta: b. Ecografía

Explicación: La ecografía de hombro es el examen de primera línea para el estudio del hombro doloroso, ya que es el más costo-efectivo y tiene un buen rendimiento, al punto de ser considerado el Gold-Standard. La RMN es el examen con mayor rendimiento, pero es caro, por lo que solo se pide cuando se

está evaluando una resolución quirúrgica (última línea de tratamiento en los casos muy graves). Además, la clínica suele ser suficiente para establecer el diagnóstico, por lo que la ecografía solo ayuda a complementarla. El tratamiento cuenta con abundante evidencia científica y consiste en: 1. Reposo relativo, frío local, AINEs y kinesioterapia motora. 2. En casos en que no responde o el dolor impide la kinesioterapia, se indica infiltración con corticoides. 3. La cirugía exclusivamente está indicada en un paciente que no responde en 6-9 meses de tratamiento no quirúrgico y, además, tiene una rotura del tendón (la rotura sola no se debe operar, es la rotura que no responde).

Fuente: Reumatología, cuestionario 6.1, P6

47. Un paciente de 70 años consulta por dolor inguinal izquierdo, de larga data, que aparece al caminar y que se ha vuelto más intenso en las últimas semanas, limitando sus actividades habituales. Al examen físico presenta dolor a la movilización de la cadera izquierda, sin signos inflamatorios. Se realiza una radiografía de cadera, que muestra marcada disminución del espacio articular, asociado a esclerosis subcondral y presencia de osteofitos acetabulares. La conducta más adecuada es:

a. Solicitar factor reumatoídeo, anticuerposantinucleares y anticuerpos anticitoplasma de neutrófilo.
b. Iniciar paracetamol oral e indicar ejercicios de fortalecimiento de cuádriceps
c. Iniciar AINES orales e indicar reposo relativo
d. Indicar inmovilización con yeso
e. Indicar kinesioterapia motora y controlar en 3 meses

Respuesta correcta: b. Iniciar paracetamol oral e indicar ejercicios de fortalecimiento de cuádriceps

Explicación: El diagnóstico es una artrosis de cadera clásica (adulto mayor con coxalgia crónica y progresiva), confirmada con la radiografía (disminución del espacio articular, osteofitos, esclerosis subcondral). El tratamiento de primera línea actualmente es algo discutible. - Históricamente, de elección ha sido el paracetamol oral (1g cada 8 horas), más baja de peso y ejercicios de fortalecimiento de cuádriceps (más útil en artrosis de rodilla, que de cadera). Lamentablemente, estudios actuales no identifican beneficios clínicamente relevantes con el paracetamol solo. Este sigue siendo el manejo de las guías ministeriales chilenas, por lo que se dejará como correcta. -De segunda línea, se indican los AINEs (tanto COX1, como COX2 son útiles, aunque los COX2, como el celecoxib, tienen menos riesgo de úlceras y daño renal). Sin embargo, estudios recientes ponen en duda lo anterior, ya que los AINEs han demostrado ser mejores que el paracetamol, por lo que podrían ir de primera línea. - Si persiste con dolor, o están contraindicados los AINES (ej. IRC), se agrega tramadol. Sin embargo, estudios actuales los desaconsejan, dado que tienen muchos efectos adversos (mareos, náuseas, caídas, dependencia). - Los corticoides intraarticulares son útiles, pero su eficacia es muy corta (1-2 meses), por lo que solo se usan para situaciones en que se requiere un alivio breve del dolor. - De última línea, se indica la cirugía de reemplazo articular (en cadera y rodilla), con buena respuesta, en la mayoría de los casos. * No sirven o no tienen evidencia el condroitín sulfato, la glucosamina y similares, el plasma rico en plaquetas o el ácido hialurónico intraarticulares y una larga lista de otras terapias. El paracetamol, según algunas recomendaciones, caería en esta lista.

Fuente: Reumatología, cuestionario 6.1, P15

48. Un paciente de 55 años consulta por dolor en el codo derecho, que aparece al realizar algunos movimientos y que es especialmente intenso al jugar tenis. Al examen físico presenta dolor a la palpación de la zona de inserción de los músculos extensores del antebrazo. La conducta más adecuada es:

a. Solicitar radiografías de codo
b. Solicitar una resonancia magnética nuclear de codo

c. Solicitar un TAC de codo

d. Iniciar AINEs, indicar reposo relativo y uso de banda de descompresión

e. Iniciar AINES e indicar inmovilización con cabestrillo

Respuesta correcta: d. Iniciar AINEs, indicar reposo relativo y uso de banda de descompresión

Explicación: Tiene una epicondilitis (lateral o codo del tenista). Se trata con AINES, reposo relativo, KNT motora y la banda de descompresión. No es necesario pedir ningún examen, aunque ante la duda diagnóstica, podría usarse la ecografía (no sirven radiografía, TAC ni se suele usar la RMN, salvo excepciones).

Fuente: Reumatología, cuestionario 6.2, P7

49. Un paciente de 65 años consulta por dolor de la rodilla izquierda de algunos meses de evolución, que aparece con la marcha y cede con el reposo. En el último tiempo el dolor se ha hecho más intenso, limitando sus actividades habituales. Al examen físico no se observan signos inflamatorios y la radiografía de rodilla muestra disminución del espacio articular y esclerosis ósea subcondral. Se inicia paracetamol, sin respuesta. La conducta más adecuada es:

a. Realizar resonancia magnética nuclear

b. Iniciar celecoxib o naproxeno por vía oral, según comorbilidad

c. Iniciar prednisona oral

d. Iniciar AINEs endovenosos

e. Iniciar colchicina

Respuesta correcta: b. Iniciar celecoxib o naproxeno por vía oral, según comorbilidad

Explicación: El diagnóstico es una artrosis de rodilla clásica (adulto mayor con gonalgia crónica y progresiva), confirmada con la radiografía (disminución del espacio articular, osteofitos, esclerosis subcondral). El tratamiento de primera línea es la educación, más ejercicios de fortalecimiento de cuádriceps (más útil en artrosis de rodilla, que de cadera) y, como fármaco, el paracetamol oral (1g c/8 horas), aunque la evidencia actual sugiere que no sirve mucho y que se debería preferir iniciar directamente con AINES (guía Minsal sigue usando el paracetamol). Si sigue con dolor, no queda duda en que se deben iniciar los AINEs. El celecoxib (COX-2) tiene menor riesgo de úlcera y falla renal que el naproxeno (COX-1). Si persiste con dolor, o están contraindicados los AINES (ej. IRC o úlcera), se puede agregar tramadol, aunque estudios recientes ponen en duda su relación beneficios / efectos adversos y hay recomendaciones que los desaconsejan fuertemente. Los corticoides intraarticulares sirven, aunque por periodos breves, de 1 a 2 meses. De última línea, la artrosis se trata con cirugía de reemplazo articular.

Fuente: Reumatología, cuestionario 6.2, P18

50. La causa más frecuente de hombro doloroso es:

a. Luxación

b. Artrosis

c. Desgarro muscular

d. Artritis

e. Patología del manguito rotador

Respuesta correcta: e. Patología del manguito rotador

Explicación: No hay mucho que explicar: la patología del manguito rotador (en especial, la afectación del tendón del supraespinoso), es la causa más frecuente de dolor de hombro.

Fuente: Reumatología, cuestionario 6.3, P5

Lumbago y cervicobraquialgia (2)

51. ¿Cuál de los siguientes corresponde a un signo de alarma en un lumbago agudo?

a. Inicio súbito
b. Dolor intenso, que limita las actividades de la vida diaria
c. Irradiación del dolor por debajo de la rodilla
d. Antecedente de episodios previos de lumbago agudo
e. Fiebre sin causa clara

Respuesta correcta: e. Fiebre sin causa clara

Explicación: La fiebre sugiere infección, cáncer o causa autoinmune, por lo que es un signo de alarma. Por el contrario, la A (súbito), B (intenso) y D (recurrente) son clásicas del lumbago mecánico común y corriente (sin signos de alarma) y la C (irradiación) simplemente es parte de una lumbociática. Recordar que la simple irradiación del dolor no es signo de alarma, pero el déficit neurológico sí lo es (debilidad, arreflexia, anestesia).

Fuente: Reumatología, cuestionario 6.1, P14

52. Un paciente de 34 años, consulta por dolor en el cuello, dorso y extremidad superior derecha, que apareció luego de levantar y mover algunos muebles. Al examen presenta paresia en la separación y aducción de los dedos, e hipoestesia en el 4° y 5° dedos derechos. ¿Qué raíz nerviosa es la afectada?

a. C5
b. C6
c. C7
d. C8
e. T1

Respuesta correcta: d. C8

Explicación: C5: abducción hombro (deltoides) y un poco bíceps; sensibilidad del hombro. C6: flexión codo y muñeca; sensibilidad pulgar (1° dedo). C7: extensión codo y muñeca; sensibilidad índice (2°) y dedo medio (3°). C8: mano y dedos; sensibilidad anular (4°) y meñique (5°). T1: mano y dedos; sensibilidad cara interna brazo Reflejo: bicicpital: C5 - C6; tricipital: C6 - C7; estilorradial: C7.

Fuente: Reumatología, cuestionario 6.1, P17 · Reumatología, cuestionario 6.2, P12

Fibromialgia (2)

53. Una paciente de 40 años, con antecedente de colon irritable, presenta fatigabilidad y dolores generalizados. En su examen físico presenta dolor a la palpación de los músculos del cuello, dorso, cara interna de las rodillas y cara lateral de los codos. El diagnóstico más probable es:

a. Polimiositis
b. Fibromialgia
c. Polimialgia reumática
d. Hipotoroidismo
e. Lupus

Respuesta correcta: b. Fibromialgia

Explicación: Es una fibromialgia clásica. Se asocia a otros cuadros dolorosos (ej. colon irritable, trastornos somatomorfos, etc.) y se caracteriza por astenia, debilidad y mialgias generalizadas, con dolor a la presión de distintos músculos. El diagnóstico es clínico, pero siempre se piden CK, TSH y un hemograma con VHS, porque se puede confundir con la polimiositis (elevación de CK), hipotiroidismo (produce mialgias) o la polimialgia reumática (eleva VHS y CK), al igual que otras patologías reumatológicas (importante no pedir más exámenes). Sin embargo, estas se caracterizan por mialgias y debilidad de predominio proximal y el cuadro descrito es una fibromialgia de libro. El tratamiento consiste en educación, manejo del estrés, ejercicios (de entrenamiento y estiramiento muscular) y, en algunos casos, moduladores del dolor (pregabalina, gabapentina, amitriptilina, venlafaxina, duloxetina, minalcipram, etc.), siendo los tricíclicos en dosis bajas, lo más usado en pacientes jóvenes.

Fuente: Reumatología, cuestionario 6.2, P13

54. Una paciente de 45 años presenta fatigabilidad y dolores musculares generalizados, asociados a ánimo bajo. Dentro de los antecedentes destaca trastorno digestivo funcional siendo tratada con dieta y trimebutino. Al examen físico, presenta dolor al palpar músculos del cuello, dorso, cuadrante superior externo de glúteos y cara lateral de los codos, sin otras alteraciones. Se solicitan exámenes, que muestran FR: 20 UI/L (VN: <15), CPK: 100 ug/L (VN: <120), hemograma normal. La conducta más adecuada es:

a. Solicitar biopsia muscular y perfil ENA
b. Iniciar antiinflamatorios no esteroidales
c. Iniciar prednisona oral
d. Iniciar metotrexato y solicitar anticuerpos anticitrulina
e. Iniciar amitriptilina en dosis bajas y ejercicio

Respuesta correcta: e. Iniciar amitriptilina en dosis bajas y ejercicio

Explicación: El cuadro clínico sugiere fuertemente una fibromialgia, cuyo principal tratamiento es la educación. El ejercicio aeróbico y de elongación tiene un rol relevante. Dentro de los fármacos que se pueden usar inicialmente están los ADTC en baja dosis (como la amitriptilina), la pregabalina y algunos antidepresivos (duloxetina y milnacipran).

Fuente: Reumatología, cuestionario 6.4, P7

Osteoporosis y dolor óseo (2)

55. Una paciente de 65 años se realiza una radiografía lumbar que muestra osteopenia radiológica, por lo que se solicita una densitometría ósea que muestra T-score: -2,1 y un Z-score: -0,9. El diagnóstico más probable es:

a. Sana
b. Osteopenia
c. Osteoporosis postmenopáusica
d. Osteoporosis secundaria
e. Enfermedad de Paget

Respuesta correcta: b. Osteopenia

Explicación: La osteopenia se define como T-score menor o igual a -1. La osteoporosis, en cambio, tiene T-score menor o igual a -2,5. Como el Z-score es mayor a -2, es de causa primaria (si fuera menor o igual a -2, sería secundaria). La enfermedad de Paget es una enfermedad de causa desconocida (probablemente genética), que afecta a los huesos y genera riesgo de deformación y fracturas. Puede manifestarse como fosfatasas alcalinas elevadas (sin síntomas) o como dolor óseo o fracturas en hueso patológico. Es

característico que tienen radiografía con lesiones "en sal y pimienta", con zonas radiopacas y otras radiolúcidas. Se observa, si es asintomática; o se trata con bifosfonatos, si tiene síntomas.

Fuente: Reumatología, cuestionario 6.2, P19

56. Una paciente de 82 años presenta un cuadro de astenia, asociado a dolor en los hombros y la espalda. Su examen físico no aporta mayor información, por lo que se realizan exámenes que muestran hematocrito: 32%, blancos: 3.000 por mm3, plaquetas: 110.000 por mm3, glicemia: 90 mg/dl, calcio: 12,0 mg/dl, colesterol: 150 mg/dl, albúmina: 3,0 g/dl, proteínas totales: 9,4 g/dl, creatinina: 3,0 mg/dl, LDH: 390 UI/L, ANA (+) en dilución 1/40, FR (-). ¿Qué patología se debe sospechar en primer lugar?

a. Déficit de vitamina B12
b. Mielodisplasia
c. Lupus sistémico de inicio tardío
d. Mieloma
e. Pelviespondiloatropatía

Respuesta correcta: d. Mieloma

Explicación: Tanto la clínica como los exámenes sugieren un mieloma múltiple. Tiene una pancitopenia, hipercalcemia, hipoalbuminemia, con hiperproteinemia y falla renal. Los ANA (+) se ven en el 5% de la población. Los dolores en los hombros y espalda parecen más dolores óseos que articulares, pero podrían ser cualquiera de los dos, pero aun así no parece una PEA, las que suelen afectar a pacientes jóvenes y tener la clásica clínica de lumbago inflamatorio, más oligoartritis asimétrica, sin marcadores positivos.

Fuente: Reumatología, cuestionario 6.4, P4

Neurología (96)

Accidente cerebrovascular (9)

1. ¿Cuál es el diagnóstico más probable frente a un paciente que presenta súbitamente imposibilidad para evocar palabras y hemiparesia derecha?

a. Accidente vascular encefálico
b. Hemorragia subaracnoidea
c. Epilepsia focal
d. Crisis miasténica
e. Meningitis herpética

Respuesta correcta: a. Accidente vascular encefálico

Explicación: La aparición súbita de signos focales (afasia y hemiparesia en este caso) es diagnóstica de AVE, ya que el diagnóstico es clínico. Si bien se debe solicitar una TAC cerebral de urgencia sin contraste, esta imagen es para diferenciar entre un AVE hemorrágico (no se tromboliza) de uno hemorrágico (se tromboliza). - La B (HSA) produce cefalea súbita e intensa y puede tener vómitos y signos meníngeos (rara vez, focales). - La C (epilepsia focal) sí puede cursar con esos síntomas, pero la afasia es rara y generalmente tienen otro tipo de manifestaciones, como movimientos involuntarios o convulsiones. - La D (miastenia) tiene debilidad fluctuante y compromiso de los oculomotores. - La E (meningitis herpética) tiene compromiso de conciencia, desorientación y convulsiones, además de fiebre y cefalea.

Fuente: Neurología, cuestionario 8.1, P7

2. Paciente de 65 años, con antecedente de hipertensión arterial, presenta dificultades para mover el hemicuerpo izquierdo. Al examen neurológico, tiene una hemiparesia facio-braquio-crural izquierda, moderada, sin alteraciones en la sensibilidad. Al tercer día se ha recuperado casi por completo. El diagnóstico más probable es:

a. Infarto lacunar
b. Crisis isquémica transitoria
c. Migraña hemipléjica
d. Accidente vascular embólico
e. Infarto aterotrombótico de circulación anterior

Respuesta correcta: a. Infarto lacunar

Explicación: Los accidentes lacunares se caracterizan por producir sólo hemiparesia o solo hemihipoestesia o ambas y tener una evolución que puede ser favorable, en el sentido que van mejorando (más de 24 horas, ya que si mejoran en menos tiempo, se trata de un accidente isquémico transitorio o AIT). Generalmente no tienen afasia ni otras alteraciones, aunque pueden presentar cefalea. Son causados por HTA (como en este caso). La D y E (AVE embólico o trombótico) tendrían una evolución mucho más desfavorable.

Fuente: Neurología, cuestionario 8.1, P15

3. Un paciente presenta marcha inestable, con aumento de la superficie de sustentación, asociada a dismetría e imposibilidad de realizar movimientos alternantes. ¿Qué patología es más concordante con el cuadro descrito?

a. Accidente vascular encefálico lacunar

b. Hemorragia cerebelosa
c. Accidente vascular talámico
d. Síndrome piramidal
e. Síndrome extrapiramidal

Respuesta correcta: b. Hemorragia cerebelosa

Explicación: Tiene un síndrome cerebeloso clásico: ataxia de la marcha, dismetría y adiadococinesia.

Fuente: Neurología, cuestionario 8.1, P17

4. Un paciente presenta de manera súbita una hemianopsia homónima derecha. La conducta más adecuada es:

a. Solicitar una punción lumbar
b. Realizar fondo de ojo
c. Solicitar TAC de cerebro de urgencia
d. Iniciar anticoagulación con heparina
e. Iniciar corticoides orales

Respuesta correcta: c. Solicitar TAC de cerebro de urgencia

Explicación: La aparición súbita de signos focales hace el diagnóstico de un accidente vascular encefálico, cuyo diagnóstico es clínico. Por tanto, se debe proseguir el estudio con un TAC de cerebro, para diferenciar entre un AVE isquémico y un AVE hemorrágico, que tienen un manejo distinto (ej. El AVE isquémico se trombolíza y el hemorrágico no). Debe hacerse de inmediato ("tiempo es cerebro"). En este caso que hay una hemianopsia homónima derecha, se debe sospechar una lesión retroquiasmática izquierda (contralateral).

Fuente: Neurología, cuestionario 8.2, P1

5. Un paciente de 60 años presenta una hemiparesia braquiocrural derecha, que inició de manera súbita y que duró cerca de 20 minutos, mejorando antes de llegar al servicio de urgencia. Al examen físico presenta normalidad del examen neurológico, aunque está muy preocupada por lo que le pasó. La conducta más adecuada es:

a. Enviar a domicilio, indicando aspirina, sin necesidad de estudio adicional
b. Enviar a domicilio, indicando control ambulatorio, para inicio de anticoagulación a permanencia
c. Hospitalizar, solicitar una neuroimagen, iniciar medidas de neuroprotección y realizar estudio de fuente embólica
d. Hospitalizar, solicitar una neuroimagen, iniciar medidas de neuroprotección y realizar trombolisis intravenosa
e. Hospitalizar, solicitar una neuroimagen y observar por 12 horas

Respuesta correcta: c. Hospitalizar, solicitar una neuroimagen, iniciar medidas de neuroprotección y realizar estudio de fuente embólica

Explicación: Tiene un accidente isquémico transitorio (TIA o AIT), cuyo diagnóstico es clínico y que se maneja exactamente igual que un AVE isquémico, es decir, se debe hospitalizar, solicitar una neuroimagen y estudiar la fuente embólica. La única diferencia, es que no requiere trombólisis, ya que se "autotrombolizó". La alternativa E habría sido una respuesta aceptable, pero la C es mejor. Tiene muy alto riesgo de AVE en el corto plazo, por lo que el estudio y manejo de la fuente embólica es fundamental. La neuroimagen debe estar normal. Si muestra una zona de infarto cerebral, algunos autores lo catalogarán como AVE, aún cuando la clínica haya sido transitoria y menor a 24 horas (ej. AVE lacunar). Si bien la

definición de AIT usa el límite de 24 horas, algunos lo consideran arbitrario y, en la práctica, suelen durar solo algunos minutos.

Fuente: Neurología, cuestionario 8.3, P12

6. Un paciente de 68 años presenta imposibilidad de evocar palabras de inicio súbito, hace 30 minutos, asociado a imposibilidad de realizar movimientos con la extremidad superior derecha. Al examen físico se constata una hemiparesia derecha de predominio braquial, asociada a una afasia de expresión. Se solicita un TAC de cerebro sin contraste, que resulta normal. La conducta más adecuada es:

a. Enviar a domicilio con reposo y control ambulatorio
b. Iniciar medidas de neuroprotección y protocolo de trombólisis endovenosa
c. Iniciar medidas de neuroprotección y mantener en observación por 24 horas
d. Solicitar TAC de cerebro con contraste
e. Iniciar de inmediato anticoagulación con heparina, iniciar medidas de neuroprotección y mantener una conducta expectante

Respuesta correcta: b. Iniciar medidas de neuroprotección y protocolo de trombólisis endovenosa

Explicación: Es una AVE isquémico, que además está dentro de la ventana para trombólisis (<4,5 horas), por lo que se debe trombolizar urgentemente, más las medidas de neuroprotección. Es un AVE porque el diagnóstico es clínico y se basa en la aparición súbita / ictal de signos focales (hemiparesia y afasia, en este caso). Es isquémico, porque el TAC descartó las hemorragias.

Fuente: Neurología, cuestionario 8.3, P16

7. Un paciente de 69 años pierde la capacidad de hablar de manera súbita. No puede decir palabras ni nombrar objetos, sin embargo, sí es capaz de entender casi todo lo que se le dice. El diagnóstico más probable es:

a. AVE con compromiso del lóbulo frontal izquierdo
b. AVE con compromiso del lóbulo parietal derecho
c. AVE con compromiso de la zona temporoparietal izquierda
d. AVE con compromiso del lóbulo occipital izquierdo
e. AVE con compromiso de la zona parietooccipital derecha

Respuesta correcta: a. AVE con compromiso del lóbulo frontal izquierdo

Explicación: Tiene una afasia de expresión, o afasia motora o afasia de Broca. El área de broca está ubicada en la corteza frontal izquierda. En cambio el área de Wernicke, encargada de la comprensión del lenguaje, está en el área parietotemporal izquierda. Dado que ambas áreas están irrigadas por la arteria cerebral media izquierda, con alguna frecuencia se afectan las dos.

Fuente: Neurología, cuestionario 8.4, P14

8. Un paciente presenta hemipareria y hemihipoestesias derechas de inicio súbito hace 3 horas. Al examen además se constata afasia. La conducta inicial es:

a. Administrar nitroprusiato endovenoso
b. Solicitar TAC de cerebro sin contraste
c. Anticoagular con heparina
d. Realizar trombolisis endovenosa
e. Realizar trombolisis intrarterial

Respuesta correcta: b. Solicitar TAC de cerebro sin contraste

Explicación: Tiene un AVE clínico (y el diagnóstico es clínico), ya que tiene signos focales de inicio ictal o súbito. Por tanto, se debe solicitar una TAC de cerebro sin contraste, para diferenciar entre un AVE hemorrágico y un AVE isquémico, que se tratan distinto (ej. el AVE isquémico recibe aspirina, trombólisis con activadores del plasminógeno y eventualmente heparina, tolo lo que está contraindicado en el AVE hemorrágico). En este caso, dado que hay afasia, lo más probable es que sea un AVE isquémico de la arteria cerebral media izquierda, dado que hay afasia y hemiparesia más hemihipoestesia derechas. La ventana de trombólisis en los AVE isquémicos, actualmente, es de 4,5 horas (antes era 3 horas y es importante entender que cada minuto que pasa significa la muerte de más neuronas. En estricto rigor, la RMN de difusión-perfusión permite identificar si hay áreas que sean recuperables con trombólisis, independientemente del tiempo transcurrido, por lo que se suele realizar en los lugares donde está disponible.

Fuente: Neurología, cuestionario 8.5, P2

9. Una paciente de 76 años, con antecedente de hipertensión arterial e hipotiroidismo, en tratamiento con hidroclorotiazida, losartán y levotiroxina, es traída a urgencia, debido a compromiso de conciencia, que inició hace 20 minutos. Al examen físico se nota paciente soporosa y desorientada, con atonía y arreflexia de las extremidades derechas. No es posible evaluar sensibilidad ni función motora, debido a que no sigue instrucciones. Sus signos vitales muestran FC: 80x', irregular, PA: 160/110 mmHg ritmo cardíaco en dos tonos, sin soplos y examen pulmonar y abdominal normales. Su hemoglucotest resulta 145 mg/dl y se solicitan exámenes generales, que solo muestran leve anemia y una TAC de cerebro sin contraste, que resulta normal. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

a. Crisis hipertensiva con encefalopatía hipertensiva
b. Crisis epiléptica no convulsiva con parálisis de Todd
c. Embolia cerebral
d. Accidente vascular encefálico lacunar
e. Accidente vascular encefálico hemorrágico

Respuesta correcta: c. Embolia cerebral

Explicación: La clínica es concordante con un accidente vascular encefálico, ya que tiene un inicio súbito y signos focales (en agudo se presenta con atonía e hiporreflexia la hemiparesia y luego evoluciona a hipertonía e hiperreflexia). Por tener una TAC normal, no puede ser hemorrágico sino que debe ser isquémico, en las primeras etapas (está en ventana de trombólisis, por llevar menos de 4,5 horas de síntomas; eso sí, los primeros minutos son los más importantes). Por tener compromiso de conciencia no parece un AVE lacunar, sino un AVE isquémico extenso. La presencia de pulso irregular orienta a una fibrilación auricular, lo que aumenta el riesgo de que sea un AVE embólico (quedará anticoagulado a permanencia, ya que el AVE da 2 como causa y como consecuencia del AVE), la clínica no es compatible con una encefalopatía hipertensiva, sino con un AVE.

Fuente: Neurología, cuestionario 8.6, P2

Hemorragia subaracnoidea y traumatismo encefalocraneano (6)

10. Un paciente consulta en el servicio de urgencia por cefalea de localización parietooccipital, muy intensa, que inició hace una hora y es de carácter opresivo. El dolor inició súbitamente y mantiene una intensidad constante. El diagnóstico de sospecha es:

a. Neuralgia de Arnold
b. Jaqueca
c. Cefalea tensional

d. Embolia cerebral
e. Hemorragia subaracnoidea

Respuesta correcta: e. Hemorragia subaracnoidea

Explicación: Es una pregunta difícil, ya que contiene muy poca información. Sin embargo, tiene dos signos de alarma que orientan fuertemente a una hemorragia subaracnoidea: inicio súbito y que sea muy intensa. La neuralgia de Arnold, también es de localización occipital y puede iniciar súbitamente, pero es un dolor de tipo neurálgico, es decir, eléctrico o en ramalazo. La cefalea tensional es de esa localización temporo-occipital, pero no es aguda, sino crónica y va empeorando hacia la tarde. La embolia cerebral, produce un accidente vascular encefálico, con signos focales súbitos, pero habitualmente sin cefalea, a diferencia del AVE hemorrágico, que sí duele y además tiene signos focales.

Fuente: Neurología, cuestionario 8.1, P1

11. La causa más frecuente de hemorragias subaracnoideas espontáneas es:

a. Trastornos de la coagulación
b. Infecciones del sistema nerviosos central
c. Rotura de aneurismas arteriales encefálicas
d. Malformaciones venosas del sistema nervioso central
e. Secundaria a hipertensión arterial

Respuesta correcta: c. Rotura de aneurismas arteriales encefálicas

Explicación: La causa más frecuente de HSA es traumática, seguida de las espontáneas, por rotura de aneurismas cerebrales. La HTA produce hemorragias intracerebrales (AVE hemorrágico).

Fuente: Neurología, cuestionario 8.3, P4

12. Un niño de 10 años cae de un segundo piso, golpeándose la cabeza contra el suelo y quedando inconsciente por al menos 10 minutos. Después de ese momento despierta algo desorientado y aquejando intenso dolor. Al examen físico presenta equimosis retroauricular. La conducta más adecuada es:

a. Solicitar radiografía de cráneo y decidir conducta según hallazgos
b. Enviar a domicilio con analgésicos y observación cuidadosa, indicando reconsulta, en caso de que aparezcan signos de alarma
c. Hospitalizar y solicitar TAC de urgencia sin contraste
d. Hospitalizar y realizar punción lumbar
e. Hospitalizar y solicitar resonancia magnética nuclear

Respuesta correcta: c. Hospitalizar y solicitar TAC de urgencia sin contraste

Explicación: Es un TEC severo, ya que tiene signos de alarma: intenso dolor (sospechar fractura o formación de hematoma) y la equimosis retroauricular o signo de Battle (sugiere fractura de la base de cráneo). Por tanto, se debe estudiar con un TAC, hospitalizar para el manejo general, con medidas de neuroprotección y manejo de las complicaciones. El solo hecho de haber estado inconsciente o desorientado no es signo de alarma, a menos que dure más de 15 minutos, o que aparezca con posterioridad. Recordar las indicaciones de TAC sin contraste: - Edad mayor a 60-65 años. - Uso de anticooagulantes. - Glasgow < 15. - Convulsiones. - Signos focales. - Signos de fractura (hundimiento, - Hipertensión endocraneana clínica: Cefalea intensa, vómitos 2 o más veces, edema de papila. - Compromiso de conciencia, convulsiones o amnesia tardías o persistentes (en cambio, no son signos de alarma si son transitorias y ocurren inmediatamente después del golpe). - Deterioro clínico.

Fuente: Neurología, cuestionario 8.3, P9

13. Un paciente de 36 años, sin antecedentes de importancia, presenta cefalea muy intensa (10/10), que inició de manera súbita hace 30 minutos y que se ha acompañado de vómitos en varias oportunidades. El dolor es de carácter opresivo y al examen físico no se aprecia focalidad neurológica. La conducta más adecuada es:

a. Realizar punción lumbar de inmediato
b. Solicitar TAC de cerebro de urgencia
c. Solicitar resonancia magnética nuclear de cerebro de urgencia
d. Administrar analgésicos y antieméticos por vía endovenosa y reevaluar en 2 horas
e. Administrar AINEs y ergotamínicos y enviar a domicilio con propanolol

Respuesta correcta: b. Solicitar TAC de cerebro de urgencia

Explicación: Es una cefalea con signos de alarma: inicio súbito y dolor muy intenso, por lo que se tiene que estudiar con una TAC de cerebro. La sospecha es una hemorragia subaracnoidea, la que también se diagnostica con la TAC sin contraste. La resonancia magnética sería la respuesta correcta ante una sospecha de tumor cerebral.

Fuente: Neurología, cuestionario 8.4, P5

14. Una paciente de 48 años, sin antecedentes de importancia, presenta cefalea de intensidad 10/10, que inició súbitamente hace 2 horas. Al examen físico se constata rigidez de nuca, sin signos focales. El diagnóstico más probable es:

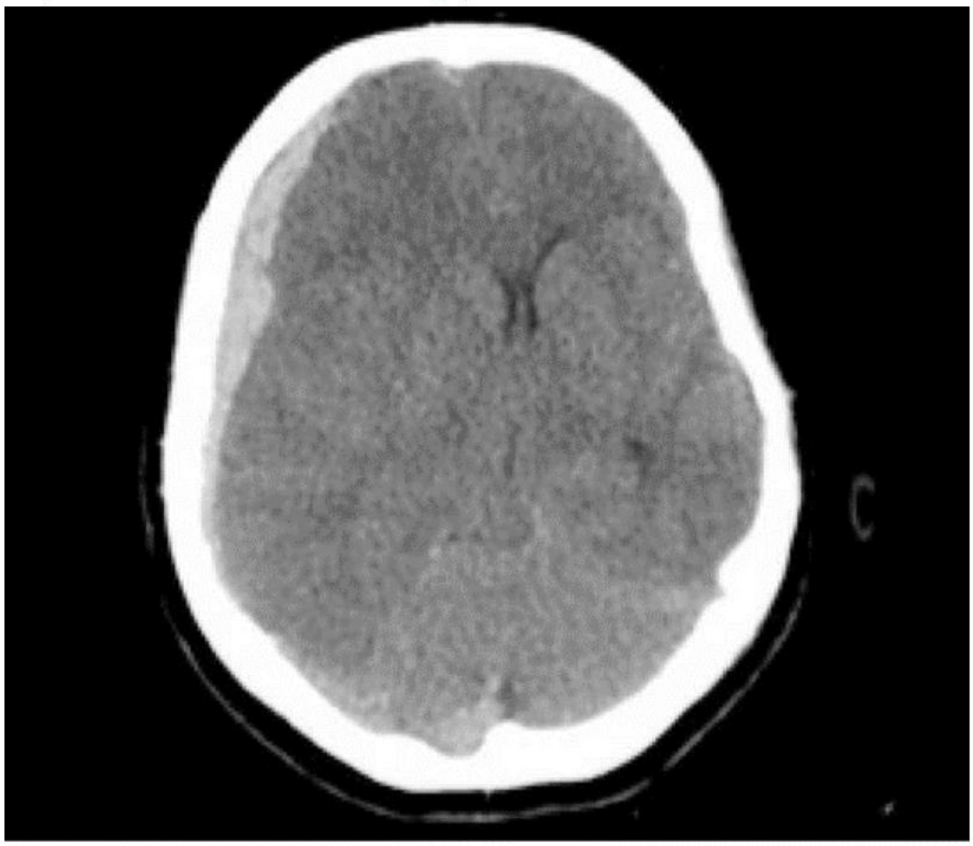
a. Meningitis aguda
b. Cefalea en racimo
c. Hemorragia subaracnoidea
d. Crisis de jaqueca
e. Accidente vascular encefálico hemorrágico

Respuesta correcta: c. Hemorragia subaracnoidea

Explicación: Es una HSA clásica: cefalea muy intensa, de inicio súbito/ictal. Además, puede tener signos meníngeos (como en este caso: rigidez de nuca). La meningitis no tiene inicio súbito y suele tener fiebre (la HSA también puede desarrollar fiebre). La cefalea en racimo tiene dolor periocular con rinorrea, epifora, ojo rojo, ptosis y miosis. La jaqueca tiene cefalea pulsátil, pfrontoparietal, son sonofobia, fotofobia y en ocasiones, aura. El AVE hemorrágico tiene signos focales, con cefalea que se instala en algunos minutos.

Fuente: Neurología, cuestionario 8.5, P12

15. Un paciente de 80 años, con antecedente de fibrilación auricular, en tratamiento con atenolol y rivaroxabán, presenta una caída, con golpe en la cabeza, evolucionando con cefalea. Se solicita una TAC de cerebro, que se muestra a continuación (fuente: https://www.medintensiva.org/). ¿Cuál es el diagnóstico más probable?



Med Intensiva. 2019;43:190

a. Accidente vascular hemorrágico
b. Hematoma extradural
c. Hemorragia subaracnoidea
d. Accidente vascular isquémico
e. Hematoma subdural

Respuesta correcta: e. Hematoma subdural

Explicación: Tiene un hematoma subdural derecho, claramente identificable, con forma de medialuna y aspecto hiperdenso (más blanco: la sangre se ve así). Suele ser traumático (aunque hay casos espontáneos) y los factores de riesgo principales son la atrofia cerebral y el uso de anticoagulantes y antiagregantes, por lo que es más frecuente en adultos mayores. Su presentación clínica es muy amplia, pudiendo tener cefalea, signos focales o compromiso de conciencia. Puede tener un intervalo lúcido entre el traumatismo y la aparición del compromiso de conciencia, dado que pasa algo de tiempo mientras se forma el hematoma y aumenta la presión intracraneana. Sin embargo, no necesariamente será un intervalo lúcido largo, como se suele enseñar. Semiológicamente el hematoma extradural se instala más rápido por ser sangramiento generalmente arterial, mientras que el hematoma subdural lo hace más lento, por ser sangramiento venoso en 3/4 de los casos. Sin embargo, en la práctica, la única forma de hacer la diferencia es con la TAC sin contraste u otra neuroimagen. El tratamiento es quirúrgico, aunque

se pueden observar los casos en que está estable y bien, sin signos de HTEC (ej. herniación o desplazamiento de la línea media cerebral), sin daño cerebral, sin crecimiento del hematoma, siendo este de menos de 1 cm de espesor.

Fuente: Neurología, cuestionario 8.6, P6

Cefaleas y neuralgias (10)

16. Existen numerosos medicamentos que sirven para prevenir la ocurrencia de ataques de migraña. Uno de estos medicamentos es:

a. Indometacina
b. Propanolol
c. Ergotamina
d. Verapamilo
e. Tramadol

Respuesta correcta: b. Propanolol

Explicación: En los pacientes con migraña muy intensa, frecuente o invalidante, como profilácticos se usan múltiples familias de fármacos. La regla general es iniciar uno, seleccionándolo según las características específicas del paciente y, si no responde, cambiarlo por otra familia de fármacos. Los más usados son: - Antidepresivos tricíclicos (ej. amitriptilina en baja dosis). - Betabloqueantes (propanolol y carvedilol). - Anticonvulsivantes (ácido valproico, topiramato). Otros que pueden servir son: - Gabaérgicos (gabapentina). - Bloqueadores del calcio (flunarizina). - Incluso IECA y ARA2 pueden tener algún rol. - Hoy también existen actualmente anticuerpos monoclonales y fármacos que bloquean el receptor CGRP (Calcitonin gene-related peptide) y que pueden ser útiles (erenumab, fremanezumab, galcanezumab, eptinezumab; rimegepant, atogepant). En la crisis sí se pueden usar el paracetamol (de elección en cuadros leves) los AINES (ketorolaco, naproxeno, etc.), los triptanes, ergotamínicos e incluso los opiáceos, corticoides, antieméticos y antipsicóticos (clorpromazina).

Fuente: Neurología, cuestionario 8.1, P19

17. Un paciente presenta cefalea intensa, pericocular, asociada a miosis y epifora ipsilaterales. El diagnóstico más probable es:

a. Accidente vascular encefálico hemorrágico
b. Accidente vascular isquémico de troncoencéfalo
c. Cáncer de pulmón
d. Esclerosis múltiple
e. Cefalea en racimo

Respuesta correcta: e. Cefalea en racimo

Explicación: Es un cluster o cefalea en racimo clásica: dolor periocular con miosis y ptosis (además puede tener inyección conjuntival = ojo rojo superficial). No se debe confundir con el glaucoma agudo que también tiene dolor ocular, pero con midriasis y ojo rojo profundo. El cáncer de pulmón puede dar un síndrome de Horner (por metástasis del ganglio estrellado), pero es un cuadro crónico de miosis y ptosis, sin dolor.

Fuente: Neurología, cuestionario 8.2, P13

18. Un paciente presenta cefalea opresiva, recurrente, localizada en la zona occipital, que se irradia al cuello. El diagnóstico más probable es:

a. Cefalea tensional
b. Jaqueca
c. Neuralgia de Arnold
d. Síndrome de hipertensión endocraneana
e. Cefalea mixta

Respuesta correcta: a. Cefalea tensional

Explicación: Es una cefalea tensional clásica: dolor temporoccipital, irradiado al cuello. Suele ser mayor en las tardes. La neuralgia de Arnold también duele en la zona occipital, pero es de tipo eléctrico (en ramalazo). La jaqueca o migraña suele ser de localización frontoparietal, de tipo pulsátil. La cefalea mixta es una mezcla de jaqueca y cefalea tensional.

Fuente: Neurología, cuestionario 8.2, P14

19. Una paciente de 56 años consulta por cefalea recurrente, de carácter opresivo, localizada en la zona temporo-occipital, la que se irradia al cuello. Suele ser mayor en las tardes y cede al dormir. El diagnóstico más probable es:

a. Síndrome de hipertensión endocraneana
b. Neuralgia de Arnold
c. Cefalea cluster (en racimo)
d. Jaqueca
e. Cefalea tensional

Respuesta correcta: e. Cefalea tensional

Explicación: Es una cefalea tensional clásica: dolor temporoccipital, irradiado al cuello. Suele ser mayor en las tardes. El síndrome de HTEC tiene cefalea matinal, holocránea, asociada a vómitos y edema de papila. La cefalea cluster suele cursar con dolor periocular, ptosis, miosis, rinorrea y ojo rojo. La neuralgia de Arnold también duele en la zona occipital, pero es de tipo eléctrico (en ramalazo). La jaqueca o migraña suele ser de localización frontoparietal, de tipo pulsátil.

Fuente: Neurología, cuestionario 8.3, P10

20. ¿Cuál de las siguientes alteraciones haría MENOS probable el diagnóstico de una neuralgia primaria del trigémino?

a. Ubicación del dolor en la zona malar y frontal de una hemicara
b. El dolor se gatilla al tocar algunas zonas de la cara
c. Presencia de alodinia
d. La movilidad de la cara es normal
e. Presencia de hipoestesia/anestesia de una hemicara

Respuesta correcta: e. Presencia de hipoestesia/anestesia de una hemicara

Explicación: La neuralgia primaria se caracteriza por dolor tipo neurálgico (tipo eléctrico, con alodinia e hiperalgesia), en cualquiera de sus ramas (nasociliar: frente; maxilar: mejilla; mandibular: mandíbula), sin otras alteraciones en el examen físico. La presencia de hipoestesia/anestesia sugiere una causa secundaria. Actualmente, tanto la neuralgia primaria como la secundaria obligan a realizar una neuroimagen (RMN). Sin embargo, en la primaria resultará normal y se tratará con carbamacepina (de

elección) u otro estabilizador nervioso (ej. gabapentina), mientras que en la secundaria se debe, además, tratar dirigidamente la causa.

Fuente: Neurología, cuestionario 8.3, P17

21. Una paciente de 48 años acude al servicio de urgencia por cefalea. Refiere que con cierta frecuencia presenta cefalea, pero que en esta oportunidad es más intensa que lo habitual y que no ha cedido con ibuprofeno y paracetamol. El dolor es de carácter pulsátil, ubicado en la zona frontal y retroocular, mayor al lado izquierdo. Aumenta con la luz y con los ruidos fuertes. Al examen físico no presenta focalidad neurológica y sus signos vitales son normales. El diagnóstico más probable es:

a. Cefalea cluster
b. Hemorragia subaracnoidea
c. Migraña
d. Cefalea tensional
e. Accidente vascular hemorrágico

Respuesta correcta: c. Migraña

Explicación: Es una migraña, jaqueca o cefalea vascular clásica: cefalea pulsátil, frontoparietal, con fotofobia y sonofobia. La cefalea cluster tiene dolor periocular, con ptosis, miosis, rinorrea y ojo rojo. La hemorragia subaracnoidea tiene inicio súbito e intensidad 10/10, con sigons meníngeos y de HTEC. La cefalea tensional es de localización temporo-occipital, irradiada al cuello. El AVE hemorrágico tiene signos focales de inicio súbito, más la cefalea y signos de HTEC.

Fuente: Neurología, cuestionario 8.3, P18

22. ¿Cuál de las opciones síntomas es MENOS compatible con una jaqueca?

a. Visión de escotomas centelleantes previo a la cefalea
b. Aumento de la cefalea con los ruidos y la luz intensa
c. Localización frontoparietal y carácter pulsátil
d. Presencia de signo de Babinski
e. Inicio del dolor en relación a ciertos alimentos

Respuesta correcta: d. Presencia de signo de Babinski

Explicación: El signo de Babinski es patognomónico del síndrome piramidal, por lo que es un signo focal, que hace pensar en otra causa de cefalea. La A, B y C son características de la jaqueca. La E (inicio con alimentos) se puede ver, ya que dentro de los desencadenantes de las crisis de jaqueca, se encuentra la exposición al sol, a las pantallas, la falta de sueño, algunos alimentos y las bebidas alcohólicas, entre otros.

Fuente: Neurología, cuestionario 8.4, P2

23. Un paciente de 38 años consulta por cefalea recurrente, intensa, que suele desencadenarse cuando duerme poco y cuando tiene sobrecarga laboral. Es de localización frontoparietal y de carácter pulsátil. Refiere que en ocasiones viene precedida por visión de luces (escotomas centelleantes) y que aumenta con la luz. Actualmente presenta 3 a 4 crisis a la semana. ¿Qué tratamiento farmacológico es más adecuado para prevenir la aparición de estas crisis?

a. Ergotamina
b. Fluoxetina
c. Sumatriptán
d. Donepezilo

e. Flunarizina

Respuesta correcta: e. Flunarizina

Explicación: Es una jaqueca o migraña clásica. El tratamiento profiláctico incluye los antidepresivos tricíclicos, el propanolol y la flunarizina (se usa poco actualmente), más los anticonvulsivantes, como el ácido valproico o el topiramato, e incluso algunos antihipertensivos como los IECA y ARA2. Además, para casos refractarios, se han desarrollado algunos anticuerpos monoclonales contra péptido relacionado con el gen de la calcitonina o su receptor. Esto sumado a evitar los desencadenantes (ej. debe dormir bien). - El tratamiento de la crisis sí incluye a los ergotamínicos y triptanes, aunque de primera línea se usa el paraceptamol y los AINEs. En las crisis más graves se agregan los ergotamínicos, triptanes, corticoides, antieméticos e incluso antipsicóticos, como la clorpromazina. - No se aconseja el uso crónico de ergotamínicos, ya que producen "cefalea de rebote". - El donepezilo es un inhibidor de la aectilcolinesterasa, que se usa en el tratamiento de las demencias.

Fuente: Neurología, cuestionario 8.5, P3

24. Un paciente de 50 años consulta por dolor en la frente derecha, de tipo neurálgico, que dura pocos segundos, pero que es muy intenso. El paciente refiere que el dolor se gatilla al tocarse la cara, pero que en ocasiones inicia de manera espontánea. Al examen físico presenta reflejos fotomotores y corneales normales, sensibilidad normal y movimientos faciales y masticatorios conservados. La conducta más adecuada es:

a. Iniciar AINEs y paracetamol oral
b. Solicitar resonancia magnética nuclear de cerebro, por sospecha de neuralgia secundaria
c. Iniciar tratamiento con carbamazepina
d. Iniciar tratamiento con opiáceos
e. Solicitar electroencefalograma

Respuesta correcta: c. Iniciar tratamiento con carbamazepina

Explicación: Dado que no tiene alteraciones en el examen físico, ni una clínica progresiva, la sospecha diagnóstica es una neuralgia primaria del trigémino (en este caso con afectación de la rama nasociliar), por lo que se debe tratar con carbamazepina oral. Actualmente se recomienda realizar una RMN a todas las neuralgias del trigémino y no solo a las que clínicamente parecen ser secundarias. En las primarias, la RMN es normal. - Si hubiese tenido alguna alteración del examen neurológico, sería una neuralgia secundaria, que siempre requiere estudio con RMN, de modo de poder identificar y tratar la causa.

Fuente: Neurología, cuestionario 8.5, P18

25. Una paciente de 38 años consulta por cefalea muy intensa, que la despertó mientras dormía. El dolor es de localización derecha, en la zona periocular y frontal, duró cerca de media hora y luego cedió, pero volvió a presentarlo una hora después, alcanzando un EVA de 10/10. Refiere que el día de ayer tuvo síntomas similares, pero menos intensos. Al examen físico, llora de dolor y no se aprecian alteraciones en el examen físico ni neurológico. ¿Cuál es la conducta inicial más adecuada?

a. Administrar ketorolaco, metoclopramida y dexametasona por vía endovenosa
b. Administrar sumatriptán subcutáneo y oxígeno al 100% por mascarilla
c. Solicitar TAC de cerebro sin contraste
d. Solicitar RMN de cerebro
e. Administrar lorazepam sublingual

Respuesta correcta: b. Administrar sumatriptán subcutáneo y oxígeno al 100% por mascarilla

Explicación: Tiene una cefalea cluster o en racimos clásica (síntomas recurrentes, en "racimos" de crisis de 15 minutos a 3 horas, habitualmente nocturnos), aunque no venga con las alteraciones que frecuentemente se describen: miosis, ptosis, inyección conjuntival ni con los desencadenantes habituales (alcohol, privación de sueño, tabaco). Se maneja en agudo con triptanes subcutáneos y oxígeno al 100%. Los analgésicos convencionales pueden servir, pero de manera secundaria. La prevención de nuevas crisis se realiza con corticoides o moduladores del dolor. Las neuroimágenes no están estrictamente indicadas, pero es recomendable pedirlas igual en los pacientes reales.

Fuente: Neurología, cuestionario 8.6, P4

Epilepsia y convulsiones (6)

26. Un niño de 10 años presenta una convulsión tónico-clónica, por los que sus padres llaman a la ambulancia. Usted lo recibe en el servicio de urgencia 15 minutos después de haber iniciado la crisis y continúa convulsionando en la fase clónica. La conducta más adecuada es:

a. Administrar oxígeno, instalar una vía venosa periférica y mantener una conducta expectante
b. Solicitar un electroencefalograma de urgencia
c. Administrar lorazepam endovenoso
d. Realizar una punción lumbar de urgencia
e. Administrar diazepam intramuscular

Respuesta correcta: c. Administrar lorazepam endovenoso

Explicación: A pesar de que aún no cumple criterios de un estatus convulsivo (necesita 30 minutos de convulsiones sin recuperación completa), la conducta es detener la crisis de inmediato. De elección se usan benzodiacepinas, en especial el Lorazepam (0,1 mg/Kg EV). Si no hay, se puede indicar diazepam.

Fuente: Neurología, cuestionario 8.1, P10

27. Un niño de 6 años presenta una convulsión tónico-clónica, de 2 minutos de duración, autolimitada. No había presentado síntomas previos. Al examen físico está en buenas condiciones, sin alteraciones de ningún tipo. Sus exámenes generales muestran un hemograma normal, así como los electrolitos plasmáticos, las pruebas hepáticas y las pruebas de función renal. El diagnóstico más probable es:

a. Meduloblastoma
b. Astrocitoma
c. Meningitis
d. Convulsión idiopática
e. Epilepsia primaria

Respuesta correcta: e. Epilepsia primaria

Explicación: Hasta ahora el diagnóstico es una primoconvulsión o "primera convulsión", dado que para hacer el diagnóstico de epilepsia se necesitan al menos dos convulsiones o una convulsión más un electroencefalograma compatible. Sin embargo, dado que se trata de un niño y que el estudio general resultó normal, lo más probable es que efectivamente sea una epilepsia primaria. Vale la pena mencionar que la primera causa de convulsiones en pediatría son las convulsiones febriles (pero no tenía fiebre) y luego las de causa tóxico-metabólica (pero el estudio está normal en este caso). Las epilepsias primarias suelen dar convulsiones generalizadas (como pareciera ser el caso). Se estudian con el electroencefalograma. Los tumores, como los astrocitomas, producen crisis focales (además de cefalea y signos focales). Se estudian con una neuroimagen (RMN, por regla general). No siempre es fácil diferenciar una crisis focal que se generaliza de una crisis primariamente generalizada. Por eso, en la

actualidad se pide tanto EEG como RMN a todos los pacientes con una primera convulsión, sin una causa evidente. De todos modos, algunos signos de "lateralización", que sugieren una causa focal son: desviación de la mirada hacia un lado o giro del cuerpo hacia un lado (crisis versivas), aura o desorientación que preceden a la convulsión, signos focales postconvulsión.

Fuente: Neurología, cuestionario 8.2, P12

28. Una paciente de 30 años presenta un cuadro caracterizado por movimientos involuntarios y rítmicos de la mano derecha, que luego se extienden al brazo derecho. Nunca pierde la conciencia, y está muy preocupada por lo sucedido. El diagnóstico más probable es:

a. Epilepsia tónico-clónica
b. Epilepsia mioclónica
c. Epilepsia tónica
d. Crisis parcial compleja
e. Crisis parcial simple

Respuesta correcta: e. Crisis parcial simple

Explicación: Es una crisis parcial o focal, porque no inicia con una convulsión generalizada, sino con los movimientos de una extremidad. Se clasifican en parcial simple y parcial compleja, dependiendo de la conexión con el medio. En este caso, por mantenerla, es de tipo simple. Si la hubiese perdido (ej. Se desorienta y actúa raro por un momento), sería compleja.

Fuente: Neurología, cuestionario 8.3, P3

29. Un paciente de 15 años presenta movimientos involuntarios de la mano izquierda, de 30 segundos de duración, que luego evolucionan a una convulsión tónicoclónica generalizada. El diagnóstico más probable es:

a. Epilepsia mioclónica
b. Epilepsia tónicoclónica
c. Lesión focal
d. Convulsión idiopática
e. Meningitis

Respuesta correcta: c. Lesión focal

Explicación: Tiene una crisis parcial compleja, secundariamente generalizada. Es parcial, porque empezó con movimientos de la mano. Es compleja, porque se desconectó del medio. Y es secundariamente generalizada, porque terminó como una crisis tónico- clónica. Las crisis parciales, de todo tipo (simples o complejas), suelen ser por lesiones focales. La importancia en saber reconocerlas es que hacen poco probable una epilepsia primaria y, además, que obligan a hacer una neuroimagen (idealmente RMN) cuanto antes. - La epilepsia mioclónica tiene mioclonías del sueño (“saltitos” al dormirse o despertar) y además convulsiones tónico-clónicas. - La epilepsia tónico-clónica tiene convulsiones tónico-clónicas a repetición, sin el pródromo parcial. - La meningitis tiene fiebre, cefalea y signos meníngeos. Si convulsiona suele ser tónico-clónico, a menos que se asocie a un absceso cerebral u otra lesión focal.

Fuente: Neurología, cuestionario 8.4, P4

30. Un paciente de 30 años, sin antecedentes previos, presenta un cuadro, caracterizado por movimientos involuntarios y repetitivos de la mano izquierda, que luego se extienden toda la extremidad y luego a la extremidad inferior izquierda, terminando con una convulsión tónico-clónica. ¿Cuál es el examen más adecuado para el estudio de este paciente?

a. Electromiografía
b. Resonancia magnética nuclear de cerebro
c. Prueba de edrofonio
d. Electroencefalograma
e. No es necesario solicitar ningún examen a menos que el cuadro se repita

Respuesta correcta: b. Resonancia magnética nuclear de cerebro

Explicación: Tiene una crisis parcial compleja, secundariamente generalizada. Las crisis parciales son causadas por lesiones focales, por lo que se debe realizar una neuroimagen, de preferencia una RMN, en busca de un tumor cerebral. - La A (EMG) se usa en el estudio de las patologías relacionadas con el nervio periférico (muestra un patrón neuropático: nervio no conduce bien): neuropatías por atrapamiento, polineuropatías, síndrome de Guillain Barré, aunque también es de utilidad en las patologías musculares o de la placa motora (muestra un patrón miopático: nervio conduce bien, pero músculo no responde bien). - La C (edrofonio) se usaba antiguamente en el diagnóstico de la miastenia gravis, en que se recuperaban transitoriamente la debilidad. Sin embargo, actualmente se prefiere hacer pruebas clínica como la prueba de la "compresa fría", en que se enfrían los párpados con una compresa con hielo y se ve cómo mejora y luego se complementa con serología (en busca de anticuerpos contra el receptor de acetilcolina) y, en algunos casos, con electromiografía, que muestra que la respuesta muscular va disminuyendo, a medida que se repiten los estímulos. - La D (EEG) se usa en el estudio de las epilepsias primerias de la infancia (no son focales, sino primariamente generalizadas). Las convulsiones siempre se deben estudiar, comenzando por los exámenes generales, en busca de alteraciones matabólicas y luego se estudian con una neuroimagen (RMN generalmente) y, si se sospecha que es una epilepsia primaria, se pide el EEG.

Fuente: Neurología, cuestionario 8.5, P14

31. Un paciente de 65 años presenta una convulsión, con relajación de esfínteres, la que fue presenciada por un familiar, quien refiere que inicialmente comenzó a actuar raro y luego de algunos segundo cayó al suelo con movimientos rítmicos de manos y pies. Refiere que las manos estaban en flexión y las extremidades inferiores en extensión, durante la crisis. Luego de eso se recuperó completamente y su examen físico es normal, con excepción de una escoriación en la espalda, debido al golpe contra un mueble, durante la caída. ¿Qué examen es más adecuado para el estudio etiológico de la convulsión?

a. Resonancia magnética nuclear
b. Punción lumbar
c. Natremia, calcemia y exámenes de función renal y hepática
d. Electroencefalograma
e. Electromiografía

Respuesta correcta: a. Resonancia magnética nuclear

Explicación: Tiene una crisis parcial compleja (actuó raro al inicio) y secundariamente generalizada (terminó como una crisis tónico-clónica). Por tanto, lo más probable es que se deba a una lesión focal, que debe ser estudiada con una neuroimagen, siendo de elección la RMN, aunque también sirve la TAC. - Las epilepsias primarias (clásicas de niños y que no son focales, sino primariamente generalizadas) se estudian con el EEG, aunque actualmente se realizan neuroimágenes igualmente, para descartar que haya una causa focal. De todos modos, no está de más recordar la importancia del a diferenciación entre epilepsias

primarias y focales: - Primarias: se estudian con EEG y se tratan solo con algunos anticonvulsivantes, que son de amplio espectro: ej. ácido valproico, topiramato, lamotrigina (la lamotrigina empeora la epilepsia mioclónica). - Secundarias: Se estudian con RMN y se tratan con la mayoría de los anticonvulsivantes, aunque se suelen usar los de espectro acotado, en especial, fenitoína y carbamazepina. Sin embargo, sirven también los demás y la elección final del anticonvulsivante depende de cada paciente. 1. Adulto mayor normal / Evaluación geriátrica / Polifarmacia / Fragilidad / Patología en anciano

Fuente: Neurología, cuestionario 8.6, P7

Demencias, delirium y encefalopatías (9)

32. Un paciente de 68 años presenta un cuadro de horas de agitación y desorientación temporoespacial. Al examen físico está muy asustado, diciendo que lo quieren matar. Sus familiares están muy preocupados. El tratamiento farmacológico más adecuado para este paciente es:

a. Levodopa
b. Donepezilo
c. Risperidona
d. Propanolol
e. Sintomático

Respuesta correcta: c. Risperidona

Explicación: Es un síndrome confusional agudo o delirium. El tratamiento es buscar y tratar la causa de base (generalmente infecciones u otras alteraciones tóxico-metabólicas). Sin embargo, además se lo puede tranquilizar con antipsicóticos en dosis bajas, generalmente haldol o haloperidol, pero también es útil la risperidona y otros antipsicóticos atípicos, que tienen una respuesta similar al haldol. Haldol y haloperidol son sinónimos. La dosis suele ser 0,5 a 1 mg vía oral, intramuscular o incluso endovenoso, aunque puede alargar el QT, por lo que la vía endovenosa se debe evitar en pacientes con riesgo de QT largo. En los pacientes con demencia por cuerpos de Lewy o Parkinson, el haldol tiene más riesgo de agravar el parkinsonismo que los antipsicóticos atípicos. De estos últimos, la quetiapina parece ser la más segura en pacientes con parkinsonismo. - Las benzodiacepinas (ej. lorazepam) sedan más rápido al paciente, pero tienen riesgo de agravar su estado confusional. Por eso, su rol en el delirium no está claro y suelen usarse solo en casos de delirium por privación de alcohol o privación de benzodiazepinas.

Fuente: Neurología, cuestionario 8.1, P8

33. Una mujer de 68 años presenta un cuadro de 12 meses de evolución de problemas de memoria, ideas paranoides y alucinaciones visuales. Presenta además caídas frecuentes y temblor de la mano izquierda. Los síntomas son fluctuantes, pero muestran una tendencia a empeorar. El diagnóstico más probable es:

a. Demencia por cuerpos de Lewy
b. Enfermedad de Alzheimer
c. Delirium
d. Demencia frontotemporal
e. Hidrocefalia normotensiva

Respuesta correcta: a. Demencia por cuerpos de Lewy

Explicación: Tiene una demencia: problema de memoria y de otras actividades, más los síntomas clásicos de la demencia por cuerpos de Lewy: alucinaciones (pueden ser visuales, auditivas, cenestésicas y suelen ser complejas) y parkinsonismo (caídas y temblor de reposo). - Por llevar 12 meses, no puede ser un delirium. Además, no describen ni alteración de la atención, ni del estado de conciencia. - La demencia

frontotemporal o de Pick tiene desinhibición del lenguaje y del comportamiento. - La hidrocefalia normotensiva tiene caídas y demencia, pero no alucinaciones ni temblor y, además, suele asociarse a una rápida evolución e incontinencia urinaria.

Fuente: Neurología, cuestionario 8.1, P18

34. Las demencias, como la enfermedad de Alzheimer, se caracterizan por:

a. Afectación motora
b. Afectación sensitiva
c. Afectación de la atención
d. Afectación de la memoria
e. Afectación cuantitativa de la conciencia

Respuesta correcta: d. Afectación de la memoria

Explicación: Lo más evidente al inicio es la pérdida de la memoria reciente. Luego, a medida que avanzan, se van afectando todas las funciones cognitivas superiores. La atención y la conciencia suelen estar conservadas, a diferencia del delirium, en que se afectan de manera aguda. Cuando la enfermedad de Alzheimer está más avanzada, comienzan a aparecer las alteraciones conductuales asociadas a demencia, que van desde conductas inapropiadas hasta agresiones.

Fuente: Neurología, cuestionario 8.2, P7

35. Un paciente de 74 años presenta agitación psicomotora de 48 horas de evolución, asociado a la idea de que fantasmas quieren matarlo. Al examen neurológico no presenta focalidad, aunque no sabe qué año es, ni dónde está. El diagnóstico más probable es:

a. Demencia por cuerpos de Lewy
b. Hidrocefalia normotensiva
c. Accidente vascular encefálico
d. Demencia frontotemporal
e. Síndrome confusional agudo

Respuesta correcta: e. Síndrome confusional agudo

Explicación: Es un síndrome confusional agudo clásico: adulto mayor desorientado y agitado, desde hace poco. Las demencias (A, B y D) son cuadros crónicos y progresivos. La por cuerpos de Lewy sí puede tener alucinaciones y un curso fluctuante, pero a largo plazo, junto con parkinsonismo. La hidrocefalia normotensiva tiene caídas, gran torpeza motora e incontinencia urinaria. La demencia frontotemporal tiene desinhibición. El AVE (C) sí tiene inicio agudo, pero se caracteriza por signos focales (ej. hemiparesia, hemihipoestesia, etc.).

Fuente: Neurología, cuestionario 8.2, P11

36. Un paciente de 69 años presenta un cuadro de dos días de evolución de desorientación e ideas paranoides. Se levantó a las 3 de la mañana y fue encontrado por su esposa en el patio, desorientado y diciendo que alguien estaba robando la casa. Ella refiere que hasta ese momento era un paciente autovalente y que se desempeñaba normalmente en sus actividades sociales. El diagnóstico más probable es:

a. Enfermedad de Alzheimer
b. Demencia por cuerpos de Lewy
c. Hidrocefalia normotensiva

d. Accidente vascular encefálico
e. Delirium

Respuesta correcta: e. Delirium

Explicación: Es un síndrome confusional agudo o delirium clásico: adulto mayor desorientado y agitado, de manera aguda. Las demencias (A, B y C) son cuadros crónicos y progresivos. La por cuerpos de Lewy sí puede tener alucinaciones y un curso fluctuante, pero a largo plazo, junto con parkinsonismo. La hidrocefalia normotensiva tiene caídas, gran torpeza motora e incontinencia urinaria. La demencia frontotemporal tiene desinhibición. El AVE (D) sí tiene inicio agudo, pero se caracteriza por signos focales (ej. hemiparesia, hemihipoestesia, etc.).

Fuente: Neurología, cuestionario 8.3, P8

37. Una paciente de 70 años presenta fallas reiteradas de la memoria, en especial de la memoria reciente. No ha presentado alucinaciones, pero últimamente ya no puede utilizar dinero ni tampoco cocinar, ya que comete muchos errores. Al examen físico no tiene focalidad neurológica, está atenta y vigil y presenta una actitud cooperadora, sin embargo, no es capaz de ubicar correctamente los números dentro de un círculo, de modo que asemejen a un reloj. El diagnóstico más probable es:

a. Enfermedad de Alzheimer
b. Demencia por cuerpos de Lewy
c. Demencia frontotemporal
d. Hidrocefalia normotensiva
e. Delirium

Respuesta correcta: a. Enfermedad de Alzheimer

Explicación: Tiene una demencia: alteraciones de la memoria y otras funciones cognitivas. Como no tiene ningún otro elemento clínico, que oriente a las demás causas de demencia, lo más probable es que sea una enfermedad de Alzheimer, ya que es la causa más frecuente de demencia. La demencia por cuerpos de Lewy tiene alucinaciones y parkinsonismo. La demencia frontotemporal tiene desinhibición. La hidrocefalia normotensiva tiene caídas, incontinencia urinaria y torpeza motora. El delirium tiene inicio agudo, con compromiso de la atención, curso fluctuante y compromiso de conciencia.

Fuente: Neurología, cuestionario 8.3, P20

38. Un paciente de 69 años presenta deterioro cognitivo, con alteraciones de la memoria reciente, asociado a caídas, rigidez y movimientos de tipo extrapiramidales. Además, tiene alucinaciones visuales complejas con cierta frecuencia. No presenta focalidad neurológica y es capaz de invertir series. El diagnóstico más probable es:

a. Demencia de Alzheimer
b. Demencia por cuerpos de Lewy
c. Demencia frontotemporal
d. Hidrocefalia normotensiva
e. Delirium

Respuesta correcta: b. Demencia por cuerpos de Lewy

Explicación: Es una demencia clásica (alteración de la memoria y deterioro cognitivo). Además, tiene los elementos característicos de la demencia por cuerpos de Lewy: extrapiramidalismo y alucinaciones complejas. La enfermedad de Alzheimer no tiene ningún otro elemento clínico, que oriente a las demás causas de demencia y es la causa más frecuente de demencia. La demencia frontotemporal tiene

desinhibición. La hidrocefalia normotensiva tiene caídas, incontinencia urinaria y torpeza motora. El delirium tiene inicio agudo, con compromiso de la atención (no invierte series), curso fluctuante y compromiso de conciencia.

Fuente: Neurología, cuestionario 8.5, P13

39. Un paciente de 68 años, con antecedente de EPOC, en tratamiento con broncodilatadores, es traído por sus familiares por desorientación y agitación psicomotora de 2 días de evolución. Además, presentó alucinaciones visuales de monstruos y no reconoce a algunos de sus familiares. Al examen físico se encuentra inatento, sin saber dónde está, ni qué año es. El diagnóstico más probable es:

a. Demencia por cuerpos de Lewy
b. Hidrocefalia normotensiva
c. Accidente vascular encefálico de arteria cerebral anterior
d. Accidente vascular encefálico de tipo lacunar
e. Delirium

Respuesta correcta: e. Delirium

Explicación: Es un síndrome confusional clásico. Adulto mayor con compromiso de la atención y de la conciencia de inicio agudo. En este caso, es por una probable infección. Es frecuente la agitación, conductas y pensamientos paranoides, las alucinaciones visuales (ej. ven personas, monstruos, etc.). - El AVE de arteria cerebral anterior puede cursar con esa clínica, pero además tendría signos focales. - El AVE lacunar generalmente no afecta la conciencia ni el habla. - La demencia por cuerpos de Lewy la hidrocefalia normotensiva son cuadros crónicos, o al menos subagudos.

Fuente: Neurología, cuestionario 8.5, P20

40. Un paciente indigente, en situación de calle, ingresa al servicio de urgencia por un cuadro de desorientación y dificultades para caminar. Al examen físico se constata estrabismo divergente, por parálisis del tercer nervio craneal izquierdo, ataxia de la marcha y desorientación temporoespacial, sin otras alteraciones. El diagnóstico más probable es:

a. Síndrome hiperglicémico hiperosmolar
b. Encefalopatía de Wernicke
c. Encefalopatía de Korsakov
d. Accidente vascular encefálico
e. Tuberculosis meníngea

Respuesta correcta: b. Encefalopatía de Wernicke

Explicación: Es una encefalopatía de Wernicke clásica: Confusión, oftalmoplejia, coma y ataxia, producida por déficit de vitamina B1 o tiamina. Se diagnostica con la clínica, pero, dado que la clínica clásica solo está presente en un tercio de los casos, la recomendación es administrar tiamina endovenosa a cualquier paciente que tenga alto riesgo (alcoholismo, desnutrición, malabsorción), ya sea que esté asintomático, pero cursando con algo que lo pueda descompensar o ya sea que se presenta con síntomas incompletos (ej. solo confusión). Sin tratamiento, suele tener un curso letal. Por ello es tan importante recordar su existencia, prevenirla y tratarla oportunamente.

Fuente: Neurología, cuestionario 8.6, P1

Trastornos del movimiento (8)

41. ¿Cuál de los siguientes síntomas es frecuente en la enfermedad de Parkinson?

a. Mioclonías y mioquimias
b. Demencia, presente desde el inicio del cuadro
c. Nistagmo
d. Retrocollis (distonía con extensión cervical)
e. Disminución de movimientos de los brazos, durante la marcha

Respuesta correcta: e. Disminución de movimientos de los brazos, durante la marcha

Explicación: La enfermedad de Parkinson se caracteriza por temblor, rigidez, bradicinesia y pérdida de los movimientos involuntarios normales (como el pestañeo, expresión facial y braceo). Puede desarrollar demencia al final, luego de muchos años. Si se asocia a demencia desde un inicio, el diagnóstico cambia a demencia por cuerpos de Lewy.

Fuente: Neurología, cuestionario 8.1, P12

42. Un paciente de 67 años consulta por temblor de la mano izquierda. Al examen se aprecia marcha insegura, con disminución del braceo y temblor de reposo, que desaparece al tomar un objeto. El tratamiento de la patología descrita es:

a. Corticoides orales
b. Antagonistas beta-adrenérgicos
c. Agonistas beta-adrenérgicos
d. Antagonistas dopaminérgicos
e. Agonistas dopaminérgicos

Respuesta correcta: e. Agonistas dopaminérgicos

Explicación: Es una enfermedad de Parkinson, porque el temblor es de reposo y por que tiene disminución del braceo. Se trata con levodopa o carbidopa (agonistas dopaminérgicos).

Fuente: Neurología, cuestionario 8.2, P3

43. Una paciente de 68 años consulta por temblor de ambas manos, mayor al lado derecho, que se intensifica especialmente al tomar un objeto, como una tasa o un lápiz. Sus movimientos y reflejos, así como la coordinación motora son normales. La conducta más adecuada es:

a. Iniciar agonistas dopaminérgicos
b. Iniciar antagonistas dopaminérgicos
c. Iniciar betabloqueantes
d. Iniciar betaagonistas
e. Solicitar resonancia magnética nuclear de cerebro

Respuesta correcta: c. Iniciar betabloqueantes

Explicación: La sospecha es un temblor esencial, que se trata con propanolol (betabloqueante). En quienes tiene contraindicación del betabloqueo, se puede usar la primidona. Que sea asimétrico orienta más a enfermedad de Parkinson (se trata con agonistas dopaminérgicos), pero el Parkinson tiene un temblor de reposo, que desaparece con el movimiento, o al tomar un objeto o adoptar una postura. En este caso, en cambio, aumenta, lo que es característico del temblor esencial, el que también puede ser asimétrico. El temblor de la cabeza y de la voz es muy sugerente de temblor esencial. No tiene signos focales ni ninguna otra alteración.

Fuente: Neurología, cuestionario 8.3, P11

44. Un paciente de 70 años presenta temblor de las extremidades superiores, algo mayor en el lado derecho. El temblor aumenta al adoptar una postura o al tomar un objeto. Su marcha es normal y es capaz de coordinar normalmente sus movimientos. No presenta disminución de la fuerza de dichas extremidades. El diagnóstico más probable es:

a. Enfermedad de Parkinson
b. Síndrome cerebeloso
c. Temblor esencial
d. Corea de Huntington
e. Esclerosis lateral amiotrófica

Respuesta correcta: c. Temblor esencial

Explicación: La sospecha es un temblor esencial, que se trata con propanolol (betabloqueante). Que sea asimétrico orienta más a enfermedad de Parkinson (se trata con agonistas dopaminérgicos), pero el Parkinson tiene un temblor de reposo, que desaparece con el movimiento, o al tomar un objeto o adoptar una postura (además, tiene bradicinesia, rigidez y desaparición del pestañeo, braceo). En este caso, en cambio, aumenta, lo que es característico del temblor esencial, que además tiene el resto del examen físico normal.

Fuente: Neurología, cuestionario 8.4, P11

45. Un paciente presenta movimientos bruscos de los brazos, que son de predominio proximal. ¿A qué tipo de síntoma extrapiramidal corresponde esta descripción?

a. Distonía
b. Disquinesia
c. Atetosis
d. Corea
e. Balismo

Respuesta correcta: e. Balismo

Explicación: - El balismo se caracteriza por movimiento de predominio proximal, bruscos. - La distonía tiene una contracción tónica de una parte del cuerpo, muy intensa y dolorosa (ej. tortícolis espasmódica: cuello se dobla tónicamente; o la crisis oculogira: ojos se van hacia arriba y no se pueden bajar). - La disquinesia tardía aparece luego de meses o años de tomar antipsicóticos y se caracteriza por movimientos reptantes de la cara, lengua y mentón, que luego evoluciona a afectación de las extremidades, temblor, rigidez. - La atetosis son movimientos reptantes y distales. - El corea con movimientos rítmicos, similar a un baile.

Fuente: Neurología, cuestionario 8.4, P13

46. ¿Cuál de los siguientes fármacos tiene más riesgo de producir síntomas extrapiramidales?

a. Bromocriptina
b. Fluoxetina
c. Risperidona
d. Lorazepam
e. Carbamazepina

Respuesta correcta: c. Risperidona

Explicación: Los síntomas extrapiramidales se producen especialmente con los antagonistas dopaminérgicos, como son los antipsicóticos y los antieméticos. También se pueden ver en otros fármacos, como en la fluoxetina o la flunarizina, pero son mucho más raros. De los antipsicóticos, los con mayor riesgo de síntomas extrapiramidales son los antipsicóticos típicos (haloperidol, clorpromazina, tioridazina). Los atípicos tienen menor riesgo (risperidona, olanzapina, aripiprazol) e incluso hay algunos con mínimo riesgo (quetiapina y clozapina, que son los recomendados en pacientes con enfermedad de Parkinson, que requieren antipsicóticos por alguna razón).

Fuente: Neurología, cuestionario 8.5, P9

47. Un paciente de 65 años presenta temblor de ambas manos, mayor al lado derecho, el que aparece en el reposo y desaparece al tomar un objeto o adoptar una posición. El diagnóstico más probable es:

a. Temblor esencial
b. Enfermedad de Parkinson
c. Corea de Huntington
d. Síndrome cerebeloso
e. Síndrome piramidal

Respuesta correcta: b. Enfermedad de Parkinson

Explicación: Es una enfermedad de Parkinson clásica, ya que tiene temblor de reposo, que desaparece al adoptar una posición. El temblor esencial, aumenta al hacerlo. El Corea de Huntington tiene movimientos, como un baile y luego evoluciona con demencia. El síndrome cerebeloso tiene un temblor de intención: solo aparece al realizar movimientos (también se llama dismetría). El síndrome piramidal tiene afectación motora, con aumento del tono y de los ROT, más signo de Babinsky.

Fuente: Neurología, cuestionario 8.5, P10

48. Una paciente de 68 años consulta por temblor de ambas manos, mayor al lado derecho, que se intensifica especialmente al tomar un objeto, como una taza o un lápiz. Sus movimientos y reflejos, así como la coordinación motora son normales. La conducta más adecuada es:

a. Solicitar resonancia magnética nuclear de cerebro
b. Iniciar antagonistas dopaminérgicos
c. Iniciar betabloqueantes
d. Iniciar betagonistas
e. Iniciar agonistas dopaminérgicos

Respuesta correcta: c. Iniciar betabloqueantes

Explicación: Tiene un temblor esencial clásico (aumenta al tomar un objeto o adoptar una postura). Se trata con betabloqueantes (propanolol) y, si están contraindicados (ej. EPOC o asma), se trata con primidona. El diagnóstico es clínico y no requiere de ningún examen ni imagen, sino solo de un completo y adecuado examen neurológico.

Fuente: Neurología, cuestionario 8.6, P5

Enfermedades neuromusculares (12)

49. Un paciente de 17 años presenta un cuadro de debilidad generalizada, asociada a parálisis facial bilateral, que se ha instaurado en pocos días. Probablemente presentará, además:

a. Miosis
b. Midriasis

c. Afasia
d. Abolición de los reflejos osteotendíneos
e. Espasticidad

Respuesta correcta: d. Abolición de los reflejos osteotendíneos

Explicación: Es un síndrome de Guillain Barré, por lo que cursa con una tetraparesia fláccida (hipotonía) y arrefléctica (abolición de los ROT). Generalmento no afecta los oculomotores (aunque una variante, el síndrome de Miller Fischer o neuropatía craneal múltiple sí lo hace y por tanto puede producir midriasis). La afasia es característica del AVE de arteria cerebral media izquierda, ya que el área de Broca y el área de Wernicke están en la corteza cerebral izquierda. La espasticidad es característica del síndrome piramidal de varios días de evolución.

Fuente: Neurología, cuestionario 8.1, P5

50. Una polineuropatía suele presentar todos los síntomas y signos mencionados a continuación, EXCEPTO:

a. Hipoestesia
b. Hiporreflexia
c. Debilidad de predominio proximal
d. Fasciculaciones
e. Atrofia muscular

Respuesta correcta: c. Debilidad de predominio proximal

Explicación: La debilidad de las neuropatías es de predominio distal. Las miopatías son las que tienen debilidad proximal. Las demás alteraciones sí se ven, ya que las neuropatías producen principalmente afectación sensitiva, pero también un síndrome de segunda monoteurona (síndrome de denervación).

Fuente: Neurología, cuestionario 8.1, P6

51. Un paciente presenta debilidad de las 4 extremidades, de 4 meses de evolución, que ha ido en aumento. La debilidad es de predominio proximal y al examen físico se aprecia hipertrofia de las masas musculares. El diagnóstico más probable es:

a. Polineuropatía
b. Síndrome piramidal
c. Síndrome de Guillain Barré
d. Miastenia gravis
e. Miopatía

Respuesta correcta: e. Miopatía

Explicación: Es una miopatía clásica, dado que la debilidad es de predominio proximal y a que no hay atrofia, sino hipertrofia. Ej. de miopatías: Distrofia muscular, polimiositis, polimialgia reumática. - La polineuropatía tendría debilidad distal, con atrofia muscular y probablemente síntomas sensitivos. - Algunas miopatías sí tienen atrofia, como la miopatía por cuerpos de inclusión, que produce atrofia de cuádriceps y de antebrazos. Sin embargo, la mayoría no tiene atrofia, sino debilidad. Algunas tienen mialgias, además. - La hipertrofia es más característica de las distrofias musculares. En este caso no se informa la edad del paciente, lo que dificulta la respuesta.

Fuente: Neurología, cuestionario 8.2, P2

52. Un paciente presenta un cuadro de parálisis progresiva, con abolición de los reflejos osteotendíneos. Además, se constata disminución del tono muscular. El diagnóstico más probable es:

a. Polineuropatía
b. Esclerosis lateral amiotrófica
c. Esclerosis múltiple
d. Síndrome de Guillain Barré
e. Miastenia gravis

Respuesta correcta: d. Síndrome de Guillain Barré

Explicación: Es un síndrome de Guillain Barré clásico: tetraparesia flácida y arrefléctica de instalación progresiva, en cosas de días. La polineuropatía suele tener gran compromiso sensitivo, suelen ser de instalación muy lenta. Pero sí pueden presentar hiporreflexia e hipotonía, porque también son un síndrome de segunda motoneurona (denervación). La esclerosis lateral amiotrófica produce un cuadro crónico de debilidad, con alteraciones de primera y segunda motoneurona mezcladas (ej. espasticidad, hiperreflexia con fasciculaciones y atrofia), sin alteración sensitiva. La esclerosis múltiple produce signos focales y en particular, neuritis óptica. La miastenia gravis produce debilidad fluctuante, con compromiso de los oculomotores.

Fuente: Neurología, cuestionario 8.2, P8

53. Un paciente de 30 años, diagnosticado de una vasculitis de Wegener, consulta por parestesias y dificultades para realizar algunos movimientos con los pies y las manos. Al examen físico presenta abolición de los ambos reflejos aquileanos y del reflejo bicipital derecho, asociado a disminución de la sensibilidad de la planta de los pies, mayor al lado derecho. Además, presenta debilidad para flectar el 3° y 4° dedos derechos y marcada dificultad para realizar la eversión de ambos pies. El diagnóstico más probable es:

a. Polineuropatía
b. Esclerosis múltiple
c. Mononeuritis múltiple
d. Esclerosis lateral amiotrófica
e. Poliradiculoneuropatía desmielinizante

Respuesta correcta: c. Mononeuritis múltiple

Explicación: Tiene afectación de múltiples nervios y raíces nerviosas. Además, por el antecedente de una vasculitis de vaso pequeño (Wegener) es altamente probable el diagnóstico de mononeuritis múltiple, la que se carcateriza por 1. Hipoestesia, 2. Hiporreflexia y 3. Paresia. Puede ser muy similar a una polineuropatía, pero la diferencia es la velocidad con la que aparece (la mononeuritis es más agresiva), la distribución de la afectación (la mononeuritis afecta solo algunos nervios, en cambio la polineuropatía tiene una afectación más difusa) y finalmente la causa de la mononeuritis múltiple son las vasculitis, mientras que las polineuropatías tiene causas metabólicas (ej. Diabetes).

Fuente: Neurología, cuestionario 8.3, P5

54. Las miopatías, a diferencia de las neuropatías, se caracterizan por:

a. Presentar debilidad de predominio proximal, sin atrofia muscular
b. Presentar debilidad de predominio proximal, con atrofia muscular
c. Presentar debilidad de predominio distal, sin atrofia muscular
d. Presentar debilidad de predominio distal, con atrofia muscular

e. Presentar debilidad de predominio distal, con hipoestesia “en guante y calcetín”

Respuesta correcta: a. Presentar debilidad de predominio proximal, sin atrofia muscular

Explicación: Las miopatías tienen debilidad proximal sin atrofia (incluso pueden tener hipertrofia muscular). Las neuropatías tienes debilidad distal, con atrofia, también distal, más hiporreflexia, fasciculaciones y, muy frecuentemente, alteraciones sensitivas. La miopatía por cuerpos de inclusión sí suele tener atrofia de muslos y antebrazos.

Fuente: Neurología, cuestionario 8.3, P7

55. Un paciente de 60 años consulta por un cuadro de 3 días de evolución, de debilidad y dificultad para caminar, que ha ido en claro aumento. Al examen se aprecia paresia de las extremidades superiores e inferiores, asociado a abolición de los reflejos osteotendíneos. El diagnóstico más probable es:

a. Miastenia gravis
b. Síndrome de Guillain Barré
c. Polineuropatía
d. Esclerosis múltiple
e. Esclerosis lateral amiotrófica

Respuesta correcta: b. Síndrome de Guillain Barré

Explicación: Es un síndrome de Guillain Barré clásico: tetraparesia flácida y arrefléctica de instalación progresiva, en cosas de días. La miastenia gravis produce debilidad fluctuante, con compromiso de los oculomotores. La polineuropatía suele tener gran compromiso sensitivo, suelen ser de instalación muy lenta. Pero sí pueden presentar hiporreflexia e hipotonía, porque también son un síndrome de segunda motoneurona (denervación). La esclerosis múltiple produce signos focales y en particular, neuritis óptica. La esclerosis lateral amiotrófica produce un cuadro crónico de debilidad, con alteraciones de primera y segunda motoneurona mezcladas (ej. espasticidad, hiperreflexia con fasciculaciones y atrofia), sin alteración sensitiva.

Fuente: Neurología, cuestionario 8.3, P14

56. Una paciente de 28 años consulta por debilidad, que aparece en especial al realizar movimientos reiterados. Su examen físico revela ptosis derecha. El diagnóstico más probable es:

a. Síndrome de Guillain Barré
b. Polineuropatía
c. Miastenia gravis
d. Miopatía
e. Esclerosis lateral amiotrófica

Respuesta correcta: c. Miastenia gravis

Explicación: Es una miastenia gravis clásica: debilidad fluctuante, con compromiso de los ojos (ptosis y estrabismo), y que empeora con los movimientos repetitivos y que es más frecuente en mujeres jóvenes (por ser autoinmune), aunque puede afectar a cualquier persona. La miastenia de Lambert Eaton, en cambio, mejora con las repeticiones. El Guillain Barré rara vez afecta los ojos, con excepción del Sd. de Miller Fischer o neuropatía craneal múltiple que sí afecta los pares craneanos con mucha intensidad.

Fuente: Neurología, cuestionario 8.4, P1

57. Un paciente de 68 años consulta por disestesias de las extremidades inferiores, de 3 meses de evolución, que se han asociado a debilidad de predominio distal. Al examen físico se constata atrofia de

los músculos del pie y disminución de la sensibilidad termalgésica en los pies. El diagnóstico más probable es:

a. Polineuropatía
b. Miastenia gravis
c. Esclerosis lateral amiotrófica
d. Síndrome de Guillain Barré
e. Mielitis transversa

Respuesta correcta: a. Polineuropatía

Explicación: Es una polineuropatía clásica: alteración sensitiva "en guante y calcetín", con mayor afectación de la sensibilidad termalgésica, más debilidad de predominio distal, hiporreflexia e hipotonía. También es frecuente el dolor de tipo neuropático (urente, con alodinia). - La miastenia solo tiene compromiso motor y no sensitivo, de predominio en los ojos y de tipo fluctuante. - La ELA solo tiene compromiso motor, de lenta evolución, con mezcla de sintomatología de primera y segunda motoneurona. Además, suele tener mucha disfagia. Las fasciculaciones son muy frecuentes, en especial en la lengua. - El Guillain Barré tiene una tetraparesia flácida y arrefléctica, de instalación subaguda. Además, puede tener dolor y afectación sensitiva. - La mielitis transversa tiene dolor de espalda, seguido de un síndrome medular, con paraparesia o tetraparesia (si es muy alta) y nivel sensitivo.

Fuente: Neurología, cuestionario 8.4, P7

58. Una mujer de 19 años consulta por debilidad de varios días de evolución, que en ocasiones es más intensa. Al examen se aprecia ptosis izquierda y se constata que se fatiga rápidamente al realizar movimientos repetitivos. El diagnóstico más probable es:

a. Síndrome de Guillain Barré
b. Miastenia Gravis
c. Polineuropatía
d. Miopatía
e. Mononeuritis múltiple

Respuesta correcta: b. Miastenia Gravis

Explicación: Es una miastenia gravis clásica: debilidad fluctuante, con compromiso de los ojos (ptosis y estrabismo), y que empeora con los movimientos repetitivos y que es más frecuente en mujeres jóvenes (por ser autoinmune), aunque puede afectar a cualquier persona. La miastenia de Lambert Eaton, en cambio, mejora con las repeticiones. El Guillain Barré rara vez afecta los ojos, con excepción del Sd. de Miller Fischer o neuropatía craneal múltiple que sí afecta los pares craneanos con mucha intensidad. La polineuropatía suele darse en un paciente diabético y produce afectación de la sensibilidad termalgésica distal, más debilidad de predominio distal. La miopatía produce debilidad proximal. La mononeuritis múltiple suele darse en pacientes con vasculitis sistémicas y se presenta como debilidad, arreflexia, hipoestesia, con afectación de varios nervios y raíces nerviosas.

Fuente: Neurología, cuestionario 8.5, P7

59. Un paciente presenta paresia de la extremidad inferior derecha. Al examen se aprecia abolición de los reflejos osteotendíneos de dicha extremidad, con disminución del tono muscular y atrofia muscular. Además, se aprecian varias fasciculaciones de distintos grupos musculares. ¿A qué nivel está localizado el problema?

a. Corteza cerebral

b. Vía piramidal
c. Asta anterior de la médula
d. Nervio periférico
e. Placa neuromuscular (placa motora)

Respuesta correcta: d. Nervio periférico

Explicación: Tiene un síndrome de denervación o de segunda motoneurona: debilidad, con atrofia, arreflexia, hipotonía y fasciculaciones. Por tanto, la afectación está en el nervio periférico. La corteza cerebral y la vía piramidal producen un síndrome piramidal o de primera motoneurona. La esclerosis lateral amiotrófica (degenera el asta anterior de la médula) produce mezcla de ambas. La afectación de la placa motora (ej. miastenia) solo produce debilidad, sin fasciculaciones, ni arreflexia, ni hipotonía. Además, la debilidad suele ser fluctuante y empeorar con los movimientos repetitivos en la miastenia gravis (mejora en la miastenia de Lambert Eaton).

Fuente: Neurología, cuestionario 8.5, P19

60. Una paciente de 25 años consulta por un cuadro de 4 días de evolución de sensación de hormigueo y debilidad en piernas y manos. Comenzó con parestesias en pies y dedos de las manos, a lo que luego se agregó debilidad para tomar objetos, que ha aumentado, agregándose sensación de debilidad para caminar y para levantar los brazos. Al examen físico tiene sensibilidad levemente disminuida a distal y paresia M3 en extremidades inferiores y M4 en extremidades superiores. Los reflejos aquileanos, rotulianos y bicipital están ausentes y el tono muscular está levemente disminuido. Refiere haber estado resfriada hasta hace una semana. La conducta más adecuada es:

a. Hospitalizar para estudio con electromiografía y punción lumbar, más manejo con IgG inmunoglobulina
b. Observar evolución y citar a control ambulatorio en 2 días, indicando signos de alarma
c. Solicitar una TAC de cerebro sin contraste
d. Solicitar una RMN de cerebro
e. Solicitar una RMN de médula espinal

Respuesta correcta: a. Hospitalizar para estudio con electromiografía y punción lumbar, más manejo con IgG inmunoglobulina

Explicación: Tiene un síndrome de Guillain Barré, que es una patología grave, potencialmente letal, que debe ser diagnosticada y tratada cuanto antes. La tetraparesia flácida y arrefléctica es lo característico. El diagnóstico es clínico, pero se suele objetivar con electromiografía, que muestra los elementos de denervación y enlentecimiento de la conducción y con la punción lumbar, que muestra la disociación albúmino-citológica (proteínas se elevan, sobre 40-45 mg/dl, mientras que las células se mantienen normales, bajo 5-10 por mm3). El tratamiento es el soporte (ej. ventilación mecánica en los casos graves), más plasmaféresis o IgG endovenosa (ambas son opciones aceptables). El pronóstico suele ser bueno, pero un 10% puede quedar con secuelas neurológicas severas y hasta un 30% queda con algún grado de debilidad.

Fuente: Neurología, cuestionario 8.6, P3

Síndromes medulares y localización de la lesión (8)

61. La hemisección medular a nivel torácico se caracteriza por:

a. Imposibilidad de mover la extremidad contralateral, ausencia de sensibilidad termalgésica ipsilateral y ausencia de sensibilidad táctil y vibratoria contralateral

b. Imposibilidad de mover la extremidad ipsilateral, ausencia de sensibilidad termalgésica contralateral y ausencia de sensibilidad táctil y vibratoria ipsilateral

c. Imposibilidad de mover la extremidad ipsilateral, ausencia de sensibilidad termalgésica ipsilateral y ausencia de sensibilidad táctil y vibratoria contralateral

d. Imposibilidad de mover la extremidad contralateral, ausencia de sensibilidad termalgésica ipsilateral y ausencia de sensibilidad táctil y vibratoria ipsilateral

e. Imposibilidad de mover la extremidad ipsilateral, ausencia de sensibilidad termalgésica contralateral y ausencia de sensibilidad táctil y vibratoria contralateral

Respuesta correcta: b. Imposibilidad de mover la extremidad ipsilateral, ausencia de sensibilidad termalgésica contralateral y ausencia de sensibilidad táctil y vibratoria ipsilateral

Explicación: La vía motora (corticoespinal) se decusa en el bulbo raquídeo, por lo que la lesión medular produce paresia ipsilateral. Lo mismo ocurre con la sensibilidad propioceptiva y táctil fina (cordones posteriores). En cambio, la sensibilidad termalgésica (haz corticoespinal) se decusa de inmediato, en la misma médula, por lo que la alteración de dicha sensibilidad es contralateral.

Fuente: Neurología, cuestionario 8.1, P11

62. Un paciente de 45 años presenta debilidad de la pierna izquierda y la mano izquierda. Al examen físico se aprecia aumento del tono muscular, con hiperrreflexia y paresia moderada de ambas extremidades, sin atrofia. Se constata que el reflejo plantar izquierdo es extensor. El diagnóstico más probable es:

a. Esclerosis lateral amiotrófica

b. Síndrome cerebeloso, con compromiso del hemisferio cerebeloso izquierdo

c. Siringomielia

d. Síndrome piramidal

e. Polineuropatía, con denervación muscular

Respuesta correcta: d. Síndrome piramidal

Explicación: Tiene una hemiparesia con aumento de los ROT y tono, más Babinski (reflejo plantar extensor), todo lo que es propio del síndrome piramidal. La lesión probablemente está en la corteza motora, o en la cápsula interna derecha.

Fuente: Neurología, cuestionario 8.1, P13

63. Un paciente presenta disminución progresiva de la sensibilidad termalgésica en las extremidades superiores, conservando la sensibilidad táctil y la sensibilidad de las extremidades inferiores, tanto táctil, como termalgésica. El diagnóstico de sospecha es:

a. Síndrome de Brown Sequard

b. Síndrome de cauda equina

c. Síndrome de arteria espinal anterio

d. Síndrome de arteria espinal posterior

e. Siringomielia

Respuesta correcta: e. Siringomielia

Explicación: Es una pregunta difícil, pero la siringomielia va produciendo dilatación del epéndimo (espacio central de la médula espinal, que tiene LCR), por lo que lo primero en afectarse es la comisura anterior, donde se decusa el haz espinotalámico lateral, es decir la sensibilidad termalgésica. Como solo se afectan las fibras que se están decusando, se produce una afectación en faja (solo en determinados niveles).

Luego, a medida que avanza, se van agregando déficits hasta terminar en el síndrome de sección medular completo (se afecta tanto sensibilidad, como motricidad, desde el punto de dilatación, hacia distal).

Fuente: Neurología, cuestionario 8.2, P5

64. Un paciente presenta hemiparesia derecha, asociada a parálisis facial izquierda. La lesión se encuentra en:

a. La corteza motora
b. La médula espinal
c. El cerebelo
d. Los núcleos de la base
e. El puente o protuberancia

Respuesta correcta: e. El puente o protuberancia

Explicación: Tiene un síndrome alterno: afectación de un hemicuerpo (hemiparesia), con afectación de nervios craneales contralaterales (parálisis facial en este caso). Por tanto, tiene una lesión del troncoencéfalo. De las alternativas, la única localizada en el troncoencéfalo es el puente de Barolio o protuberancia anular (además que el facial tiene su núcleo ahí). La corteza motora tendría hemiparesia solo de un lado (cara y hemicuerpo). La médula tendría paraparesia o tetraparesia.

Fuente: Neurología, cuestionario 8.2, P6

65. El síndrome cerebeloso se caracteriza por todo lo siguiente EXCEPTO:

a. Pérdida de la propiocepción
b. Temblor de intención
c. Adiadococinesia
d. Ataxia
e. Hipotonía

Respuesta correcta: a. Pérdida de la propiocepción

Explicación: Es una pregunta difícil, pero el cerebelo se encarga de la coordinación muscular y no tiene funciones sensitivas, ni siquiera propioceptivas. Sin embargo, sí recibe mucha información propioceptiva, para poder cumplir con su función de coordinación motora. La lesión de sus hemisferios se caracteriza por dismetría (temblor de intención), adiadococinesia (imposibilidad de realizar movimientos alternantes, de manera coordinada) e hipotonía ipsilaterales. Además, la lesión del vermix tiene nistagmo multidireccional, vértigo de tipo central, ataxia de la marcha.

Fuente: Neurología, cuestionario 8.3, P1

66. Un paciente presenta paresia de las extremidades inferiores, con hiperrreflexia y aumento del tono muscular de dichas extremidades. Además, se constata un reflejo plantar extensor. ¿En qué lugar se encuentra la lesión con mayor probabilidad?

a. Corteza motora
b. Nervio periférico
c. Tronco encefálico
d. Médula espinal
e. Placa motora

Respuesta correcta: d. Médula espinal

Explicación: Tiene una paraparesia, con afectación de primera motoneurona o síndrome piramidal (Babinski, hiperreflexia e hipertonía). Por tanto, la lesión está en el sistema nervioso central. Por ser paraparesia, lo más probable es que esté en la médula. La corteza motora y el troncoencéfalo tienen hemiparesia. El nervio periférico tiene clínica de segunda motoneurona (denervación). La placa motora tiene la clínica de la miastenia gravis.

Fuente: Neurología, cuestionario 8.4, P6

67. Un paciente pierde la propiocepción, la sensibilidad táctil fina y la sensibilidad vibratoria de las extremidades inferiores. ¿Dónde está la lesión con mayor probabilidad?

a. En el asta anterior de la médula
b. En la corteza sensitiva
c. En el tálamo
d. En los cordones anteriores de la médula (corticoespinales)
e. En los cordones posteriores de la médula

Respuesta correcta: e. En los cordones posteriores de la médula

Explicación: - Los cordones posteriores llevan la información sensitiva de tipo vibratoria, propioceptiva y táctil fina. Esta clínica se puede dar en la embolia de la arteria espinal posterior. - El asta anterior es el lugar donde hacen sinapsis la primera y segunda motoneurona, por lo que su lesión produce alteración motora mezcladas (ej. Esclerosis lateral amiotrófica). - La lesión de la corteza sensitiva produce hemihipoestesia contralateral. - La lesión del tálamo también produce hemihipoestesia contralateral. - Los cordones anteriores de la médula tienen la información motora, por lo que su afectación produce paraparesia. Recordar que la decusación motora se produce en el bulbo raquídeo, en la zona llamada "decusación de las pirámides" (zona anterior del bulbo). La decusación sensitiva de los cordones posteriores también se produce en el bulbo raquídeo, en la zona posterior llamada "decusación sensitiva". La decusación sensitiva de la sensibilidad táctil termalgésica se produce en la misma médula, en la comisura anterior.

Fuente: Neurología, cuestionario 8.5, P1

68. Un paciente con un accidente vascular del hemisferio cerebeloso izquierdo presentará, con mayor probabilidad:

a. Paresia e hipertonía de las extremidades superior e inferior izquierdas
b. Paresia e hipertonía de las extremidades superior e inferior derechas
c. Dismetría y adiadococinesia de las extremidades superior e inferior izquierdas
d. Dismetría y adiadococinesia de las extremidades superior e inferior derechas
e. Paraparesia

Respuesta correcta: c. Dismetría y adiadococinesia de las extremidades superior e inferior izquierdas

Explicación: La afectación del hemisferio cerebeloso produce dismetría (temblor de intención) y adiadococinesia (imposibilidad de realizar movimientos alternantes) ipsilaterales, ya que el cerebelo se comunica con los hemisferios cerebelosos contralaterales, que a su vez se comunica con las extremidades contralaterales (ipsilaterales al cerebelo).

Fuente: Neurología, cuestionario 8.5, P4

Pares craneales y vía visual (12)

69. Un paciente sufre un traumatismo encefalocraneano y evoluciona con visión doble. Al examen físico se aprecia estrabismo convergente, e imposibilidad de mirar a la derecha con el ojo derecho. El diagnóstico más probable es:

a. Lesión de III nervio cranea (oculomotor)
b. Lesión de IV nervio cranea (troclear)
c. Lesión de VI nervio cranea (abducens)
d. Lesión del fascículo longitudinal medial
e. Síndrome de Horner

Respuesta correcta: c. Lesión de VI nervio cranea (abducens)

Explicación: III: imposibilidad de mirar hacia arriba, medial y abajo. Ptosis y midriasis. Estrabismo divergente. IV: imposibilidad de mirar hacia inferomedial. Estrabismo algo divergente. VI: imposibilidad de mirar hacia lateral. Estrabismo convergente. FLM: imposibilidad de mirar hacia medial, en la mirada conjugada. Nistagmo. Sin las demás alteraciones del III nervio craneal. Horner: ptosis, miosis y anhidrosis de la mitad de la cara.

Fuente: Neurología, cuestionario 8.1, P4

70. Un paciente sufre una lesión en la cintilla óptica derecha. ¿Qué alteración esperaría encontrar en la campimetría?

a. Hemianopsia bitemporal
b. Hemianopsia homónima derecha
c. Hemianopsia homónima izquierda
d. Amaurosis derecha
e. Amaurosis izquierda

Respuesta correcta: c. Hemianopsia homónima izquierda

Explicación: Las lesiones retroquiasmáticas: cintilla, radiación y lóbulo occipital, producen hemianopsia homónima contralateral. La lesión de quiasma produce hemianopsia bitemporal (A). La lesión de nervio óptico produce amaurosis ipsilateral.

Fuente: Neurología, cuestionario 8.1, P16

71. ¿Cuál de las siguientes alteraciones NO suele presentarse en la parálisis facial periférica idiopática?

a. Hipoestesia malar
b. Imposibilidad de levantar la ceja
c. Hiperacusia
d. Disgeusia
e. Desviación de la comisura labial

Respuesta correcta: a. Hipoestesia malar

Explicación: La hipoestesia demuestra afectación del trigémino (V nervio craneal) y la afectación de otro nervio craneal es muy sugerente de causa central. También orienta a central, que haya posibilidad de levantar la ceja o arrugar la frente, por lo que la imposibilidad de hacerlo (B) es de parálisis periférica. La hiperacusia y disgeusia se producen porque una rama del facial (la cuerda del tímpano) inerva al músculo tensor del tímpano y a la lengua (para el sabor).

Fuente: Neurología, cuestionario 8.1, P20

72. Un paciente sufre una parálisis facial periférica. ¿Qué alteración es MENOS compatible con este diagnóstico y obliga a sospechar una causa central?

a. Lagoftalmo
b. Disgeusia
c. Disminución de la sensibilidad del trago
d. Debilidad de los músculos masticatorios
e. Hiperacusia

Respuesta correcta: d. Debilidad de los músculos masticatorios

Explicación: La debilidad de los músculos masticatorios es por afectación del trigémino (V nervio craneal) y la afectación de otro nervio craneal apunta a que es de tipo central. El lagoftalmo es la imposibilidad de cerrar el ojo, ya que el músculo orbicular del párpado es inervado por el nervio facial. La hiperacusia y disgeusia se producen porque una rama del facial (la cuerda del tímpano) inerva al músculo tensor del tímpano y a la lengua (para el sabor). Lo mismo ocurre con la sensibilidad del trago (de hecho si hay un herpes zóster del facial, se producen vesículas en el trago: síndromde Ramsey Hunt).

Fuente: Neurología, cuestionario 8.2, P4

73. La asociación de midriasis, ptosis y estrabismo es característica de:

a. Síndrome de Horner
b. Parálisis del tercer nervio craneal
c. Lesión del fascículo longitudinal medial
d. Infarto de protuberancia anular
e. Miastenia gravis

Respuesta correcta: b. Parálisis del tercer nervio craneal

Explicación: III: imposibilidad de mirar hacia arriba, medial y abajo. Ptosis y midriasis. Estrabismo divergente. Horner: ptosis, miosis y anhidrosis de la mitad de la cara IV: imposibilidad de mirar hacia inferomedial. Estrabismo algo divergente. FLM: imposibilidad de mirar hacia medial, en la mirada conjugada. Nistagmo. Sin las demás alteraciones del III nervio craneal. Protuberancia: síndrome alterno, con afectación del V al VIII nervio craneales. Miastenia gravis: debilidad fluctuante, con ptosis y estrabismo, pero sin midriasis (excepto en la miastenia de Lambert Eaton, en que sí puede haber, pero es muy rara).

Fuente: Neurología, cuestionario 8.2, P9

74. Un paciente presenta dificultades para ver, caracterizadas por la pérdida de una parte importante del campo visual izquierdo de ambos ojos. De entre las siguientes alternativas, ¿dónde se encuentra localizada la lesión con mayor probabilidad?

a. Quiasma óptico
b. Cintilla óptica derecha
c. Lóbulo occipital izquierdo
d. Nervio óptico derecho
e. Nervio óptico izquierdo

Respuesta correcta: b. Cintilla óptica derecha

Explicación: Tiene una hemianopsia homónima izquierda, por lo que tiene una lesión retroquiasmática contralateral (cintilla, radiación o lóbulo occipital derecha). Las lesiones del quiasma producen hemianopsia o cuadrantopsia bitemporal. Las lesiones del nervio óptico producen amaurosis ipsilateral.

Fuente: Neurología, cuestionario 8.3, P2

75. Un paciente de 60 años consulta por desviación de la comisura labial, de inicio súbito, hace algunas horas. Al examen presenta imposibilidad de sonreír y arrugar el mentón con el lado derecho de la cara, asociado a debilidad de los músculos masticatorios del mismo lado. Puede fruncir el ceño y arrugar la frente, de ambos lados, con normalidad. El diagnóstico más probable es:

a. Síndrome de Guillain Barré
b. Cefalea cluster
c. Síndrome de Ramsey Hunt
d. Parálisis de Bell
e. Parálisis facial central

Respuesta correcta: e. Parálisis facial central

Explicación: Es una parálisis facial. Es de tipo central, ya que puede arrugar la frente y fruncir el ceño (en la periférica se afecta toda la hemicara) y además porque tiene afectación del trigémino (V nervio craneal), ya que se afecta la masticación. Por tanto, se debe solicitar una neuroimagen de urgencia.

Fuente: Neurología, cuestionario 8.3, P6

76. Un paciente presenta estrabismo, asociado a ptosis y midriasis izquierdas. El diagnóstico más probable es:

a. Afectación del tercer nervio craneal
b. Afectación del sexto nervio craneal
c. Síndrome de Claude Bernard Horner
d. Miastenia gravis
e. Afectación del fascículo longitudinal medial

Respuesta correcta: a. Afectación del tercer nervio craneal

Explicación: III: imposibilidad de mirar hacia arriba, medial y abajo. Ptosis y midriasis, con estrabismo divergente. IV: imposibilidad de mirar hacia inferomedial. Estrabismo algo divergente. VI: imposibilidad de mirar hacia lateral. Estrabismo convergente. FLM: imposibilidad de mirar hacia medial, en la mirada conjugada. Nistagmo. Sin las demás alteraciones del III nervio craneal. Horner: ptosis, miosis y anhidrosis de la mitad de la cara. Miastenia gravis: ptosis y estrabismo fluctuantes, más debilidad fluctuante también.

Fuente: Neurología, cuestionario 8.3, P13

77. Un paciente presenta imposibilidad de mirar hacia la derecha con el ojo izquierdo. El resto de los movimientos oculares están conservados. Además, se aprecia leve nistagmo del ojo derecho al mirar a la derecha. El diagnóstico más probable es:

a. Lesión del tercer nervio craneal
b. Lesión del cuarto nervio craneal
c. Lesión del sexto nervio craneal
d. Lesión del ganglio estrellado
e. Lesión del fascículo longitudinal medial

Respuesta correcta: e. Lesión del fascículo longitudinal medial

Explicación: La afectación del fascículo longitudinal medial se caracteriza por imposibilidad de mirar hacia medial, en la mirada conjugada, sin las demás alteraciones del III nervio craneal. Además, puede tener nistagmo. - III: imposibilidad de mirar hacia arriba, medial y abajo. Ptosis y midriasis. Estrabismo divergente. - IV: imposibilidad de mirar hacia inferomedial. Estrabismo algo divergente. - VI: imposibilidad de mirar hacia lateral. Estrabismo convergente. - Ganglio estrellado: síndrome de Horner, es decir, ptosis, miosis y anhidrosis de la mitad de la cara.

Fuente: Neurología, cuestionario 8.4, P3

78. Un paciente presenta estrabismo convergente, con imposibilidad de mirar hacia la derecha con el ojo derecho. El resto de los movimientos oculares están conservados. El diagnóstico más probable es:

a. Lesión del tercer nervio craneal
b. Lesión del cuarto nervio craneal
c. Lesión del sexto nervio craneal
d. Lesión del séptimo nervio craneal
e. Lesión del fascículo longitudinal medial

Respuesta correcta: c. Lesión del sexto nervio craneal

Explicación: III: imposibilidad de mirar hacia arriba, medial y abajo. Ptosis y midriasis. Estrabismo divergente. IV: imposibilidad de mirar hacia inferomedial. Estrabismo algo divergente. VI: imposibilidad de mirar hacia lateral. Estrabismo convergente. VII: imposibilidad de realizar movimientos de la cara, incluyendo cerrar el ojo (se produce lagoftalmo). FLM: imposibilidad de mirar hacia medial, en la mirada conjugada. Nistagmo. Sin las demás alteraciones del III nervio craneal.

Fuente: Neurología, cuestionario 8.5, P5

79. Un paciente de 30 años presenta parálisis facial derecha de 3 horas de evolución. Al examen físico se constata parálisis de toda la hemicara, incluyendo la frente, sin alteración de los movimientos masticatorios, ni de la sensibilidad. No presenta otros síntomas y sus signos vitales son normales. La conducta más adecuada es:

a. Observar evolución
b. Solicitar resonancia magnética nuclear e indicar control ambulatorio con neurólogo
c. Iniciar antidepresivos tricíclicos e indicar control ambulatorio
d. Hospitalizar, solicitar TAC de cerebro sin contraste e iniciar medidas de neuroprotección
e. Iniciar prednisona oral, valaciclovir oral e indicar lubricación ocular y control ambulatorio

Respuesta correcta: e. Iniciar prednisona oral, valaciclovir oral e indicar lubricación ocular y control ambulatorio

Explicación: Es una parálisis facial periférica clásica (afectación de toda la hemicara, sin signos focales). Por tanto, se debe tratar con corticoides orales (prednisona), protección ocular y ejercicios de movilidad de la cara. El aciclovir o valacilovir no están indicados en la mayoría de los casos (a pesar que son causados por reactivación de virus herpes simplex, salvo que se trate de un síndrome de Ramsey Hunt (con vesículas en el trago), de que tenga otras manifestaciones de herpes (ej. herpes cutáneo) o que la debilidad sea demasiado severa (discutible), como en este caso. Los corticoides son más importantes que los antivirales. - Si hubiese sido central (ej. afectación de otro nervio craneal o hemiparesia o posibilidad de arrugar la frente), sería correcto el solicitar una RMN.

Fuente: Neurología, cuestionario 8.5, P17

80. Un paciente presenta parálisis facial de 2 horas de evolución. Al examen se constata que conserva la capacidad de arrugar la frente y levantar la ceja, sin embargo, no puede sonreír. La conducta más adecuada es:

a. Indicar prednisona oral
b. Indicar Aciclovir oral
c. Indicar prednisona + Aciclovir oral
d. Solicitar electromiografía
e. Hospitalizar y solicitar una neuroimagen de urgencia

Respuesta correcta: e. Hospitalizar y solicitar una neuroimagen de urgencia

Explicación: Es una parálisis facial central, ya que mantiene la capacidad de arrugar la frente, lo que es característico de las parálisis faciales de causa central. Por tanto, se debe estudiar con una neuroimagen, ya que la causa más frecuente es el accidente vascular encefálico (AVE). - Si hubiese sido periférica (sin signos focales, ni afectación de otros pares craneanos, ni posibilidad de arrugar la frente), la conducta correcta habría sido la prednisona sola. - Solo si hubiese tenido vesículas en el trago (síndrome de Ramsey Hunt), sería necesario, además, el aciclovir o valaciclovir, aunque también es aceptable dejarlos en una parálisis facial periférica muy severa o con algún otro signo de infección por herpes (ej. vesículas en la cara).

Fuente: Otorrinolaringología, cuestionario 2.1, P18

Infecciones del sistema nervioso central (5)

81. Identifique la asociación incorrecta entre el microorganismo causante de meningitis y el tratamiento antibiótico de elección:

a. Streptococcus pneumoniae – Ceftriaxona
b. Neisseria meningitides – Ceftriaxona
c. Listeria monocytogenes – Ampicilina
d. Haemophilus influenzae – Ampicilina
e. Escherichia coli – Ceftriaxona

Respuesta correcta: d. Haemophilus influenzae – Ampicilina

Explicación: El Haemophilus influenzae también se trata con Ceftriaxona.

Fuente: Neurología, cuestionario 8.1, P9

82. El análisis de líquido cefalorraquídeo, en un paciente con meningitis viral, se caracteriza por:

a. Pleocitosis de tipo mononuclear, con glucorraquia normal
b. Pleocitosis de tipo mononuclear, con glucorraquia disminuida
c. Elevación de las proteínas, sin pleocitosis
d. Pleocitosis, sin elevación de las proteínas
e. Bandas oligoclonales de inmunoglobulinas

Respuesta correcta: a. Pleocitosis de tipo mononuclear, con glucorraquia normal

Explicación: La meningitis viral se caracteriza por pleocitosis mononuclear, con glucorraquia normal (mayor a 40 mg/dl). Suelen ser por enterovirus o virus respiratorios. En el caso de la meningoencefalitis herpética, además de la pleocitosis mononuclear, se pueden ver abundante hematíes crenados (LCR hemorrágico). - La meningitis tuberculosa es mononuclear con disminución de la glucorraquia (B). - El

síndrome de Guillain Barré tiene elevación de las proteínas, sin pleocitosis (disociación albúmino-citológica). - La esclerosis múltiple tiene bandas oligoclonales de inmunoglobulinas.

Fuente: Neurología, cuestionario 8.2, P10

83. ¿Qué tratamiento antibiótico es más adecuado para un paciente de 30 años, con una meningitis bacteriana aguda?

a. Ceftriaxona + vancomicina
b. Ampicilina + vancomicina
c. Ceftriaxona + clindamicina
d. Cefepime + metronidazol
e. Imipenem

Respuesta correcta: a. Ceftriaxona + vancomicina

Explicación: La meningitis bacteriana aguda de los adultos suele ser por neumococo, meningococo y Haemophilus, todos los que son cubiertos por la ceftriaxona o el cefotaximo (cefalosporinas de tercera generación). * La vancomicina se agrega para cubrir al neumococo resistente, cuando hay riesgo de resistencia. Si bien antes la tasa de prevalencia de resistencia en Chile era baja, ha subido mucho, por lo que actualmente se recomienda agregar siempre vancomicina, hasta haber descartado la presencia de neumococo. - Los corticoides actualmente están recomendados a todas las edades, mientras no se haya descartado la presencia de neumococo, ya que disminuyen las secuelas causadas por este patógeno. - La ampicilina se agrega en el embarazo y los adultos mayores, para cubrir además Listeria. Recomendación de antibióticos empíricos actuales: * Hasta 1 mes de edad: ampicilina + cefotaximo. Busca cubrir SGB, listeria y Gram (-). * Niños y adultos: Ceftriaxona + vancomicina + dexametasona. Busca cubrir neumococo, haemofilus y meningococo. * Mayores de 60 años y embarazo: Agregar ampicilina, para cubrir listeria. * Neurocirugía o TEC abierto: asegurar agregar cobertura para pseudomona y S. aureus. Ej. Cefepime + vancomicina.

Fuente: Neurología, cuestionario 8.3, P19

84. Un paciente es diagnosticado de meningitis meningocócica por la cepa W-135. El tratamiento antibiótico más adecuado es:

a. Imipenem
b. Ceftriaxona
c. Vancomicina
d. Rifampicina
e. Moxifloxacino

Respuesta correcta: b. Ceftriaxona

Explicación: El meningococo se trata con ceftriaxona, cefotaximo, o bien con penicilina en dosis altas.

Fuente: Neurología, cuestionario 8.4, P12

85. Un paciente presenta fiebre alta y compromiso de consciencia cualitativo. Al examen físico se aprecia rigidez de nuca, signo de Brudzinsky y de Kerning. Se realiza punción lumbar, que da salida a un líquido cefalorraquídeo con 240 células, 85% de mononucleares y 15% de polimorfonucleares, glucosa 20 mg/dl y proteínas 112 mg/dl. El diagnóstico más probable es:

a. Meningitis bacteriana aguda
b. Encefalitis herpética

c. Meningitis tuberculosa
d. Meningitis por enterovirus
e. Hemorragia subaracnoidea

Respuesta correcta: c. Meningitis tuberculosa

Explicación: Es una meningitis tuberculosa, porque tiene pleocitosis (elevación de las células) de predominio mononuclear (MN), con glucosa baja (<40 mhg/dl). Si bien el diagnóstico definitivo se realiza identificando el bacilo de Koch en el LCR (baciloscopías, cultivo o PCR para TBC), las pruebas específicas no tienen un rendimiento muy alto, por lo que el estudio habitual del LCR suele ser de mucha utilidad para confirmar directamente e iniciar el tratamiento. Clínicamente, es muy similar a la meningitis bacteriana, con la diferencia que la meningitis tuberculosa tiene un inicio subagudo y suele cursar con focalidad neurológica o parálisis de los nervios craneales, alteraciones que son más raras en las meningitis bacterianas agudas. El tratamiento se debe iniciar con la sola sospecha y consiste en los 4 fármacos habituales (rifampicina, isoniacida, pirazinamida y etambutol) por 2 meses, seguido de 2 fármacos por 7-10 meses más (total tratamiento: 9 a 12 meses). - Las meningitis bacterianas tienen predominio polimorfonuclear (PMN), con glucosa baja. - La meningitis viral (enterovirus) es de predominio mononuclear (MN), con glucosa normal. - La meningitis herpética es igual a la viral, pero con líquido hemorrágico. - La HSA muestra líquido hemorrágico con xantocromía o con glóbulos rojos crenados (a diferencia de la punción hemorrágica, que tiene sangre recién extraída, sin crenación de los glóbulos rojos).

Fuente: Neurología, cuestionario 8.5, P15

Hipertensión endocraneana y tumores cerebrales (3)

86. Un paciente presenta cefalea de predominio matinal, asociado a náuseas y vómitos ocasionales. Se solicita un fondo de ojo que muestra edema de papila bilateral. No presenta signos focales y la resonancia magnética nuclear es normal. El diagnóstico más probable es:

a. Cefalea Cluster
b. Síndrome de hipertensión endocraneana
c. Tumor cerebral
d. Hidrocefalia
e. Migraña

Respuesta correcta: b. Síndrome de hipertensión endocraneana

Explicación: Tiene la triada clásica del síndrome de HTEC: cefalea matinal, vómitos y edema de papila. Dado que puede ser un tumor cerebral, hay que pedir una imagen, que en este caso lo descartó. Por tanto, el diagnóstico más probable es un pseudotumor cerebral, también llamado HTEC idiopática.

Fuente: Neurología, cuestionario 8.1, P14

87. Un paciente de 34 años presenta cefalea de un mes de evolución, progresiva, que es mayor en las mañanas. Además, ha convulsionado en una oportunidad. El diagnóstico más probable es:

a. Jaqueca con aura
b. Tumor cerebral
c. Epilepsia primaria
d. Meningitis tuberculosa
e. Esclerosis múltiple

Respuesta correcta: b. Tumor cerebral

Explicación: Tiene una sospecha de hipertensión endocraneana (HTEC), por la cefalea de predominio matinal. La convulsión orienta mucho a tumor cerebral. Se debe pedir una RMN de cerebro y, mientras, iniciar carbamacepina, fenitoína u otro anticonvulsivante que cubra bien las convulsiones focales (recordar que hay anticovulsivantes de amplio espectro y otros que solo sirven para las de tipo focal). - La jaqueca no convulsiona y es de predominio en la tarde (al igual que la cefalea tensional). No tiene signos de HTEC. - La epilepsia primaria y la esclerosis múltiple sí pueden convulsionar, pero no tienen HTEC. - La meningitis tuberculosa tendría fiebre y signos meníngeos. Sí podría tener signos de HTEC y convulsionar.

Fuente: Neurología, cuestionario 8.4, P8

88. Un paciente de 34 años consulta por cefalea de 2 semanas de evolución, que suele ser más intensa en la mañana y que lo despierta en la noche. Además, presenta náuseas y vómitos con frecuencia. El examen físico no tiene focalidad neurológica. La conducta más adecuada es:

a. Indicar analgésicos orales y observar evolución
b. Solicitar un TAC de cerebro con contraste
c. Solicitar un electroencefalograma
d. Realizar una punción lumbar
e. Solicitar una angioresonancia cerebral

Respuesta correcta: b. Solicitar un TAC de cerebro con contraste

Explicación: El diagnóstico más probable es un síndrome de hipertensión endocraneana (HTEC), dado que tiene cefalea de predominio nocturno y matinal (aumenta al estar recostado), asociado a vómitos y náuseas. Le falta el edema de papila, por lo que lo primero a hacer es el fondo de ojo. Luego, se debe estudiar con una neuroimagen, de preferencia una RMN, ya que es mejor vara ver tumores cerebrales. Si no está la opción, se debe marcar un TAC de cerebro con contraste (ya que se busca un tumor). La angioresonancia sirve para buscar aneurismas y lesiones vasculares. La punción lumbar está contraindicada en la HTEC, por riesgo de enclavamiento.

Fuente: Neurología, cuestionario 8.5, P8

Esclerosis múltiple (2)

89. Una paciente de 23 años presenta una neuritis óptica, que es manejada con corticoides, con buena evolución. Dos meses después presenta un cuadro de hemiparesia derecha, que se instala en 2 días. El diagnóstico más probable es:

a. Síndrome de Guillain Barré
b. Esclerosis múltiple
c. Accidente vascular encefálico
d. Tumor cerebral
e. Miastenia gravis

Respuesta correcta: b. Esclerosis múltiple

Explicación: Es una esclerosis múltiple clásica: afecta más a mujeres jóvenes (aunque puede ocurrir a cualquier edad). Se caracteriza por producir neuritis óptica (amaurosis, con escape pupilar) y toda una variedad de signos focales (por la desmielinización del SNC), tanto sensitivos como motores (en este caso, hemiparesia). El síndrome de Guillain Barré no afecta el nervio óptico (porque tiene mielina central y el Sd. G-B solo afecta los nervios periféricos). Además, produce tetraparesia flácida y arrefléctica y no

hemiparesia. El AVE tiene inicio súbito (no instalación en 2 días) y además no produce neuritis óptica. El tumor cerebral suele tener HTEC (cefalea, náuseas y edema de papila), más signos focales y convulsiones. La miastenia gravis solo tiene síntomas motores (no neuritis óptica), con debilidad fluctuante y astenia y mucho compromiso de los oculomotores, con ptosis, estrabismo y diplopía.

Fuente: Neurología, cuestionario 8.1, P3

90. Una mujer de 30 años presenta un cuadro que se instala en una semana, caracterizado por hemiparesia derecha, asociada a amaurosis derecha, con un defecto pupilar aferente. Además, presenta hipoestesia de la extremidad inferior izquierda. El diagnóstico más probable es:

a. Infarto de troncoencéfalo
b. Infarto lacunar
c. Síndrome de Guillain Barré
d. Infarto de arteria cerebral posterior
e. Esclerosis múltiple

Respuesta correcta: e. Esclerosis múltiple

Explicación: Es una esclerosis múltiple clásica, tanto por ser una mujer joven, como especialmente por tener una neuritis óptica (amaurosis, con escape pupilar) y signos focales. Se estudia con RMN de cerebro y médula y se trata con corticoides en agudo (si no responde, se puede hacer plasmaféresis). Entre las crisis, se trata con interferón, aunque actualmente han demostrado ser bastante mejores algunos anticuerpos monoclonales, en especial nalizumab (anticuerpo contra proteínas leucocitarias necesarias para atravesar la barrera hematoencefálica) y los anticuerpos anti-linfocito B (anti-CD20), como el rituximab, ocrelizumab y ofatumumab). - El infarto de troncoencéfalo generalmente cursa con compromiso de conciencia (se afecta la vía activante ascendente) y un síndrome alterno (afectación de un hemicuerpo, con afectación de los nervios craneales contralaterales). - El infarto lacunar suele presentarse con hemiparesia o hemihipoestesia, o con ambas, sin afasia ni compromiso de conciencia y suele tener una evolución favorable. - El AVE de arteria cerebral posterior evoluciona con hemihipoestesia de predominio crural y afectación del campo visual.

Fuente: Neurología, cuestionario 8.4, P10

Vértigo (2)

91. Un paciente de 60 años presenta vértigo de inicio súbito, muy intenso, que inició hace cerca de 3 horas. Al examen físico presenta lateropulsiones a derecha y nistagmo horizontal, con fase rápida a izquierda. Ha vomitado en varias oportunidades y no se atreve a caminar, porque se cae hacia el lado derecho. El diagnóstico más probable es:

a. Accidente vascular de troncoencéfalo
b. Accidente vascular de cerebelo
c. Accidente vascular de arteria cerebral anterior
d. Esclerosis múltiple
e. Neuronitis vestibular

Respuesta correcta: e. Neuronitis vestibular

Explicación: Tiene un vértigo de tipo periférico: intenso, con nistagmo horizontal y lateropulsiones hacia un solo lado, sin signos focales, ni cerebelosos. De las opciones, la única que produce vértigo periférico es la neuronitis vestibular, que además se caracteriza por tener un vértigo constante, de varios días de evolución. Se trata con antivertiginosos, siendo actualmente de elección el lorazepam u otra

benzodiacepina. - La A (AVE troncoencefálico), B (AVE cerebeloso) y D (Esclerosis múltiple) pueden producir vértigo, pero de tipo central (ej. nistagmo multidireccional). - La C (AVE de ACA) no produce vértigo, sino hemiparesia e hemihipoestesia de predominio crural.

Fuente: Neurología, cuestionario 8.3, P15

92. ¿Cuál de las siguientes alteraciones es compatible con un vértigo de origen periférico?

a. Asociación a hipoacusia
b. Nistagmo muldireccional
c. Asociación a hemiparesia
d. Asociación a parálisis facial
e. Asociación a hipoestesia facial

Respuesta correcta: a. Asociación a hipoacusia

Explicación: La hipoacusia es característica de la enfermedad de Ménière, que es una causa frecuente de vértigo periférico. También se puede ver en la parálisis vestibulococlear. - El nistagmo multidireccional es de vértigo central. En el periférico hay nistagmo horizontal, que "escapa de la lesión". - La hemiparesia es un signo focal, que orienta al origen central. - La parálisis facial (VII nervio craneal) y la hipoestesia facial (V nervio craneal) sí pueden verse en un vértigo periférico (ej. un neurinoma del acústico que comprometa dichos nervios; ej2. una laberintitis aguda que comprometa el facial). Sin embargo, obligan a descartar una causa central, ya que la afectación de cualquiera de los otros nervios craneales sugiere una causa central.

Fuente: Neurología, cuestionario 8.5, P16

Radiculopatías y lumbociática (3)

93. Un paciente presenta cervicobraquialgia, luego de trabajar limpiando una acequia. El dolor se irradia a la extremidad superior derecha, por la cara posterior del brazo y antebrazo, hasta los dedos índice y medio. Además, presenta disminución del reflejo tricipital ipsilateral. La raíz afectada es:

a. C5
b. C6
c. C7
d. C8
e. T1

Respuesta correcta: c. C7

Explicación: Las raíces nerviosas no siguen un patrón estricto, mezclándose sus funciones, con las raíces próximas, pero lo más frecuente es que sean de la siguiente forma: C5: sensibilidad hombro; abducción hombro (deltoides). C6: sensibilidad cara lateral de brazo y antebrazo y de pulgar; flexión de codo y mano. C7: sensibilidad cara posterior brazo y antebrazo y del índice y dedo medio; extensión de codo y de muñeca y dedos. C8: sensibilidad cara medial de antebrazo y del los dedos anular y meñique; movimientos abducción y aducción de los dedos. T1: sensibilidad cara medial del brazo: movimientos abducción y aducción de los dedos. Reflejos: Bicipital (C5 y C6) y estilorradial (C6 y C7).

Fuente: Neurología, cuestionario 8.1, P2

94. ¿Cuál de las siguientes es indicación de estudio con RMN en un paciente con una lumbociática?

a. Edad menor a 50 años
b. Déficit neurológico progresivo

c. Dolor de 2 semanas de duración
d. Dolor muy intenso que limita los movimientos de la espalda
e. Dolor de inicio súbito

Respuesta correcta: b. Déficit neurológico progresivo

Explicación: El déficit neurológico es un signo de alarma, por lo que debe ser estudiado con RMN. El inicio súbito y el dolor muy intenso son característicos del lumbago mecánico. Otros signos de alarma son: baja de peso, antecedente de cáncer, osteoporosis, traumatismo, uso de corticoides, fiebre, duración mayor a 6 semanas, lumbago mayor con el reposo. La simple irradiación del dolor no es signo de alarma, sino que es una simple lumbociática. El déficit neurológico, en cambio, sí lo es.

Fuente: Neurología, cuestionario 8.5, P6

95. Un paciente de 30 años presenta lumbago, irradiado a la extremidad inferior izquierda. Al examen físico se constata una leve paresia a la extensión de la rodilla, con disminución del reflejo rotuliano. Además, tiene hipoestesia en la cara medial de la pierna, hasta el maléolo medial. ¿Qué raíz es la afectada con mayor probabilidad?

a. S2
b. S1
c. L5
d. L4
e. L2

Respuesta correcta: d. L4

Explicación: L1: Sensibilidad zona inguinal. L2-L4: Sensibilidad de cara anterior del muslo, extensión de la rodilla y reflejo rotuliano. También la aducción del muslo. L4, además, da la sensibilidad de la cara medial de la pierna y participa en la dorsiflexión del pie y la extensión de los dedos, junto a L5. L5: Ningún reflejo. Sensibilidad de cara posterior del muslo y anterior de la pierna y el empeine. Extensión de los ortejos, en especial del primero. Dorsiflexión del pie. También abducción del muslo. S1: Reflejo aquileano. Sensibilidad cara posterior del muslo y pierna, también planta del pie, más el borde externo (5° ortejo). Flexión plantar del pie. S2-S4: Sensibilidad del periné y zona pudenda. Control de esfínteres y erección.

Fuente: Neurología, cuestionario 8.5, P11

Intoxicaciones (1)

96. Un niño presenta un cuadro de temblor, sialorrea y dificultades para caminar. Al examen físico se constata miosis de ambos ojos. La madre cree que pudo haber ingerido algún medicamento o algún tóxico. ¿Qué sustancia es la más probable?

a. Opiáceos
b. Organofosforados
c. Cocaína
d. Antidepresivos tricíclicos
e. Benzodiacepinas

Respuesta correcta: b. Organofosforados

Explicación: La intoxicación por organofosforados (insecticidas) se caracteriza por una triada: temblor, sialorrea y miosis, más la dificultad motora. Antídoto: atropina. - Lo opiáceos presenta compromiso de conciencia, depresión respiratoria y miosis puntiforme. Antídoto: naloxona. - La cocaína (adrenérgico)

tiene HTA, taquicardia, sudoración y midriasis. Se usan benzodiacepinas (relativamente contraindicado el betabloqueo, por riesgo de crisis hipertensiva). - Los ADTC (anticolinérgicos) tienen taquicardia, boca seca, compromiso de conciencia, íleo paralítico y midriasis. No hay antídoto. - Las BDZ tienen compromiso de conciencia y generalmente signos vitales normales, aunque los casos graves pueden tener depresión respiratoria. Antídoto: flumazenil, aunque su duración es muy corta y tiene riesgo de convulsiones y síndrome de abstinencia, por lo que se uso es controvertido.

Fuente: Neurología, cuestionario 8.4, P9

Psiquiatría (99)

Trastornos del ánimo (15)

1. Una paciente de 23 años presenta un cuadro de ánimo bajo, anhedonia y desgano, de 3 meses de evolución, que inició luego de una ruptura sentimental. Ha subido 10 Kg de peso en este tiempo y refiere que duerme gran parte del día, ya que no tiene ganas de hacer nada. El diagnóstico más probable es:

a. Depresión psicótica
b. Distimia
c. Depresión melancólica
d. Trastorno adaptativo
e. Depresión atípica

Respuesta correcta: e. Depresión atípica

Explicación: La depresión atípica se caracteriza por alza de peso, hipersomnia, sensibilidad al rechazo, craving por dulces, reacción a estímulos positivos). Los IMAOs (fenelcina, seleginina) históricamente han sido el tratamiento de elección en este tipo de depresión, ya que, antes de que existieran los IRS, los IMAOs demostraron ser mejor que los tricíclicos en este tipo de depresión. Aún siguen siendo una opción aceptable. Sin embargo, actualmente, la mayor seguridad de los IRS ha hecho que la mayoría de recomendaciones internacionales los prefieran como fármacos de primera línea. Sin embargo, el Eunacom, probablemente aún considera a los IMAOs como los fármacos de elección.

Fuente: Psiquiatría, cuestionario 1.1, P6

2. Una paciente es diagnosticada de depresión, por lo que inicia fluoxetina 20 mg al día. Usted la controla 10 días después y ella le comenta que se sigue sintiendo igual de triste y que los medicamentos que le prescribieron no le han hecho ningún efecto. La conducta más adecuada es:

a. Educar y mantener el tratamiento
b. Educar y aumentar la dosis de fluoxetina
c. Educar y añadir duloxetina al tratamiento
d. Educar y remplazar la fluoxetina por venlafaxina
e. Educar y derivar a especialista

Respuesta correcta: a. Educar y mantener el tratamiento

Explicación: Es normal que el tratamiento antidepresivo demore en empezar a hacer efecto hasta 4-6 semanas. Por eso, si lleva menos de 4 semanas, simplemente se la debe educar. Si llevara más de 4 semanas, sería recomendable reemplazar el IRS por un antidepresivo dual, como la duloxetina o venlafaxina.

Fuente: Psiquiatría, cuestionario 1.1, P7

3. Un adolescente de 17 años presenta un cuadro de ánimo bajo y disfórico, asociado a anhedonia de 18 meses de evolución, sin otros síntomas. No presenta ideación suicida, pero siente que no es una persona feliz. El diagnóstico más probable es:

a. Depresión
b. Distimia
c. Trastorno de personalidad
d. Trastorno bipolar

e. Trastorno adaptativo

Respuesta correcta: b. Distimia

Explicación: Es una distimia clásica, ya que lleva más de 1 año (2 años en adultos) con tristeza, pero sin cumplir con los criterios de una depresión mayor. Se trata igual que la depresión.

Fuente: Psiquiatría, cuestionario 1.1, P16

4. Usted controla a un paciente de 25 años, diagnosticado de depresión hace un mes, momento en que se inició fluoxetina 20 mg/día. Él refiere estar totalmente bien, ya sin depresión. Habla bastante y cambia fácil de tema, relatando que se metió a un curso de chino mandarín, porque es el idioma del futuro y además está haciendo mucho ejercicio, aprovechando que está lleno de energía. Además, cuenta que está durmiendo cerca de 5 horas al día, pero eso no le molesta, ya que no necesita dormir más. La conducta más adecuada es:

a. Mantener el tratamiento
b. Disminuir la dosis de fluoxetina a 10 mg/día
c. Mantener el tratamiento y agregar ácido valproico
d. Cambiar la fluoxetina por un inhibidor de la monoaminoxidasa
e. Suspender el tratamiento y derivar a especialista

Respuesta correcta: e. Suspender el tratamiento y derivar a especialista

Explicación: Tiene un viraje de depresión a manía, por lo que su diagnóstico es un trastorno bipolar. Por tanto, se tiene que suspender los antidepresivos (están todos absolutamente contraindicados en el trastorno bipolar) y se debe derivar al especialista. Sin embargo, también habría sido correcto iniciar el tratamiento con estabilizadores del ánimo (litio, anticonvulsivantes o antipsicóticos), ya que el T. bipolar no psicótico, puede ser manejado por un médico general, con conocimiento suficiente de salud mental. Algo importante es que actualmente se recomienda como primera línea a la quetiapina para el manejo de la depresión bipolar.

Fuente: Psiquiatría, cuestionario 1.2, P12

5. Un paciente sufre la separación con su esposa hace un mes, quien lo acusó de haberle sido infiel. Él evoluciona muy triste, llorando con frecuencia y pensando constantemente en lo injusto que fue todo, porque él nunca fue infiel. Refiere insomnio importante, despertando a las 4 de la mañana y que de inmediato empieza a pensar en que su mujer lo dejó y lo acusó injustamente. Además, presenta baja de peso de 6 kilogramos desde el inicio del cuadro. Dice que no tiene ganas de trabajar ni de hacer nada. El diagnóstico más probable es:

a. Trastorno de estrés agudo
b. Trastorno de estrés postraumático
c. Trastorno adaptativo
d. Trastorno depresivo
e. Reacción normal

Respuesta correcta: d. Trastorno depresivo

Explicación: Tiene un hecho gatillante claro y además tiene marcados síntomas anímicos (tristeza, llanto, insomnio y baja de peso), por lo que se trata de una depresión reactiva. Si hubiese sido menos intensa, sin alteraciones del peso, por ejemplo, sería correcto el trastorno adaptativo. Si bien tiene reexperimentación del hecho, no se trata de un hecho que ponga en riesgo la vida, ni tiene hiperalerta, evitación o ansiedad relativa al hecho, como para pensar en un T. de estrés.

Fuente: Psiquiatría, cuestionario 1.2, P13

6. Un paciente de 25 años reprueba por segunda vez un mismo ramo. Un mes después, evoluciona con ánimo irritable y tristeza, pensando en abandonar la Universidad, aun cuando solo le resta un año para terminar su carrera. Se siente inútil, come muy poco, ha dejado sus actividades sociales y presenta insomnio, despertando muy temprano, sin poder volver a dormir, ya que piensa constantemente en lo tonto y miserable que es. El diagnóstico más probable es:

a. Trastorno adaptativo
b. Depresión
c. Trastorno disociativo
d. Trastorno de estrés postraumático
e. Fobia social

Respuesta correcta: b. Depresión

Explicación: Dado que tiene un evento gatillante claro y síntomas anímicos, puede tratarse tanto de una depresión reactiva, como de un trastorno adaptativo. La intensidad de los síntomas hace pensar más en una depresión, ya que tiene insomnio, alteración del apetito e incluso ha pensado en abandonar la carrera a un año de salir. Si fuera menos intenso, lo más correcto sería un trastorno adaptativo.

Fuente: Psiquiatría, cuestionario 1.3, P4

7. Un paciente consulta por anhedonia y ánimo triste, asociado a baja de peso, desconcentración y desesperanza, de un mes de evolución. Al preguntar dirigidamente, refiere que un año atrás pasó por un periodo de euforia, en el que gastó todos sus ahorros, dormía poco y salía a fiestas todos los días, haciendo muchos amigos nuevos, pero que al final no resultaron ser amigos verdaderos. El examen físico es normal. ¿Qué fármaco es el más adecuado para el tratamiento de este paciente?

a. Quetiapina
b. Antidepresivos tricíclicos
c. Antidepresivos duales o nóveles
d. Antidepresivos inhibidores de la recaptura de serotonina
e. Antidepresivos inhibidores de la recaptura de serotonina.

Respuesta correcta: a. Quetiapina

Explicación: Tiene un episodio depresivo, pero su relato da cuenta de que sufrió una manía anteriormente, por lo que el diagnóstico es un trastorno bipolar en fase depresiva. Tratamiento del trastorno bipolar (ha cambiado, ya que los antipsicóticos han demostrado ser muy buenos estabilizadores del ánimo, en especial, aripiprazol, risperidona, quetiapina y olanzapina): 1. Lo primero y más importante es que están contraindicados todos los antidepresivos. 2. El episodio agudo se trata con litio, anticonvulsivantes y/o antipsicóticos. - Manía aguda (2 fármacos): idealmente litio más antipsicótico. Aceptable valproato o carbamacepina más antipsicótico. Si está agitado y agresivo, de elección, haloperidol e incluso se puede mezclar con lorazepam. - Hipomanía (1 fármaco): actualmente se recomiendan más los antipsicóticos que el litio o anticonvulsivantes, aunque cualquiera es una opción aceptable. Si falla, se trata como una manía. - Episodios mixtos y cicladores rápidos (4 o más episodios en un año) actualmente se tratan igual que la manía (litio o valproato más antipsicótico). - Depresión bipolar (1 fármaco): actualmente se recomiendan los antipsicóticos, en especial, quetiapina. Recordar que los antidepresivos están contraindicados. Como alternativa, se pueden usar los anticonvulsivantes.

Fuente: Psiquiatría, cuestionario 1.3, P7

8. Una paciente, diagnosticada de depresión, inicia tratamiento con citalopram a dosis estándar. Dos semanas después acude a la consulta y refiere que no ha presentado mejoría y que se sigue sintiendo igualmente deprimida. La conducta más adecuada es:

a. Indicar una dosis más alta de citalopram
b. Reemplazar el citalopram por un antidepresivo dual
c. Reemplazar el citalopram por fluoxetina
d. Agregar un nuevo antidepresivo al tratamiento
e. No realizar cambios

Respuesta correcta: e. No realizar cambios

Explicación: Es normal que el tratamiento antidepresivo demore en empezar a hacer efecto hasta 4-6 semanas. Por eso, si lleva menos de 4-6 semanas, simplemente se la debe educar. Si llevara más de 4-6 semanas, sería recomendable reemplazar el IRS por un antidepresivo dual, como la duloxetina o venlafaxina. Si lleva entre 4 y 6 semanas, es aceptable tanto cambiar como mantener el tratamiento.

Fuente: Psiquiatría, cuestionario 1.3, P18

9. Una paciente presenta ánimo bajo y labilidad emocional y sentimiento de rechazo por parte de sus pares. Ha subido cerca de 20 kilogramos en 4 meses, pesando 83 Kg, porque anda "ansiosa" y come compulsivamente chocolates y pasteles. Además, refiere que duerme cerca de 12 horas al día y que le cuesta mucho salir de la cama. ¿Qué tratamiento es el más adecuado?

a. Paroxetina más quetiapina
b. Venlafaxina
c. Fenelcina
d. Risperidona
e. Litio

Respuesta correcta: c. Fenelcina

Explicación: Tiene una depresión atípica, la que suele cursar con hipersomnia y alza de peso. Los IMAOs (fenelcina, seleginina, moclobemida) históricamente han sido el tratamiento de elección en este tipo de depresión, ya que, antes de que existieran los IRS, los IMAOs demostraron ser mejor que los tricíclicos en este tipo de depresión. Aún siguen siendo una opción aceptable. Sin embargo, actualmente, la mayor seguridad de los IRS ha hecho que la mayoría de recomendaciones internacionales los prefieran como fármacos de primera línea. Sin embargo, el Eunacom, probablemente aún considera a los IMAOs como los fármacos de elección.

Fuente: Psiquiatría, cuestionario 1.3, P19

10. Una paciente de 24 años consulta por cefalea crónica. Al preguntarle, refiere que durante los últimos 2 años se ha sentido desganada, sin iniciativa, con la sensación de que el tiempo está pasando, sin nada bueno para ella y con pesimismo respecto a su futuro. Refiere que se sintió un poco mejor cuando fue de vacaciones al sur, pero eso solo duró 2 semanas y luego volvió a su situación basal. El diagnóstico más probable es:

a. Trastorno de personalidad
b. Distimia
c. Depresión mayor
d. Trastorno de ansiedad generalizada
e. Trastorno bipolar

Respuesta correcta: b. Distimia

Explicación: Tiene una distimia clásica (también llamada depresión menor): ánimo bajo o disforia, por más de 2 años, sin cumplir criterios de depresión mayor.

Fuente: Psiquiatría, cuestionario 1.3, P20

11. Paciente de 75 años, con antecedente de hipertensión y dislipidemia en tratamiento, viudo desde hace 2 años. Es traído por su hija quien refiere que ha estado muy decaído. Al entrevistarlo refiere gran sentimiento de inutilidad, además presenta fatigabilidad, problemas con memoria a corto plazo, insomnio y apetito disminuido. Usted diagnostica depresión. ¿Cuál es el fármaco de elección para el tratamiento en este paciente?:

a. Carbamazepina
b. Seleginina
c. Amitriptilina
d. Sertralina
e. Venlafaxina

Respuesta correcta: d. Sertralina

Explicación: Tiene una depresión. Por ser adulto mayor, de elección se deben usar los IRS, ya que tienen muy pocos efectos adversos. Además, por su menor riesgo de interacciones medicamentosas, se suele preferir la sertralina o el citalopram o escitalopram en el adulto mayor (escasa evidencia, en comparación con otros IRS). De segunda línea, se pueden usar la venlafaxina, duloxetina y mirtazapina (amntidepresivos duales). La paroxetina, los tricíclicos y los IMAOs se evitan en lo adultos mayores, por mayor riesgo de efectos adversos.

Fuente: Psiquiatría, cuestionario 1.4, P19

12. Paciente de 24 años, sin antecedentes, es diagnosticada de depresión, por lo que inicia fluoxetina 20 mg al día. Usted la controla 30 días después y ella le comenta que se siente mucho mejor, con buen ánimo, sueño regulado, apetito normal y sin cansancio, por lo que no sabe si debe suspender el tratamiento. La conducta más adecuada es:

a. Mantener el tratamiento
b. Aumentar la dosis de fluoxetina
c. Disminuir la dosis de fluoxetina
d. Suspender la fluoxetina y enviar a domicilio
e. Suspender la fluoxetina y derivar a especialista de manera urgente

Respuesta correcta: a. Mantener el tratamiento

Explicación: Dado que ha respondido bien (y rápido), se le debe educar sobre que hay que mantener los medicamentos, por al menos 6 meses, desde la remisión completa de los síntomas depresivos. De lo contrario, existe alto riesgo de recurrencia. Si estuviese con demasiado ánimo y se sospechara una manía, lo correcto habría sido suspender y derivar.

Fuente: Psiquiatría, cuestionario 1.4, P20

13. Una paciente es despedida de su trabajo, en el que llevaba cerca de 10 años. Durante el mes siguiente presenta ánimo depresivo y llanto frecuente, ya que piensa que no conseguirá otro trabajo y que no podrá pagar sus deudas. Por esto tiene dificultades para dormir, ya que despierta muy temprano con la idea de que es una fracasada y está llena de problemas y también tiene dificultades para quedarse dormida.

Refiere que llora casi todos los días, por lo menos 5 veces y que no tiene ganas de hacer nada. El diagnóstico más probable es:

a. Depresión
b. Distimia
c. Trastorno adaptativo
d. Fobia social
e. Trastorno de estrés postraumático

Respuesta correcta: a. Depresión

Explicación: Tiene un evento gatillante claro y síntomas anímicos, por lo que puede ser una depresión reactiva o un trastorno adaptativo de tipo depresivo. Dada la gran intensidad del cuadro (llorar todo el día, tener insomnio y algún grado de delirio de ruina: está fracasada y arruinada), lo más probable es que sea una depresión. La importancia de saber diferenciar ambos cuadros se radica en que el tratamiento es distinto: el T. adaptativo solo requiere psicoterapia, generalmente breve, mientras que la depresión, suele requerir un tratamiento prolongado, que incluya fármacos antidepresivos.

Fuente: Psiquiatría, cuestionario 1.5, P4

14. ¿Cuál es el tratamiento de elección de la depresión en el adulto mayor?

a. Antidepresivos inhibidores de la monoaminoxidasa
b. Antidepresivos tricíclicos
c. Antidepresivos duales
d. Antidepresivos inhibidores de la recaptura se serotonina
e. Antidepresivos + antipsicóticos atípicos

Respuesta correcta: d. Antidepresivos inhibidores de la recaptura se serotonina

Explicación: De elección se usan los IRS, por tener menos efectos adversos que los demás antidepresivos (todos tienen la misma eficacia contra la depresión). Además, por tener menos interacciones medicamentosas, se usa más la sertralina, el citalopram o el escitalopram en el adulto mayor.

Fuente: Psiquiatría, cuestionario 1.5, P8

15. Un paciente consulta en un centro de atención primaria por un cuadro caracterizado por ánimo bajo, anhedonia, insomnio, baja de peso e ideas de muerte, de un mes de evolución. Al ser interrogado, relata que un año antes presentó un cuadro de ánimo irritable, con disminución de las necesidades de sueño, en el que hizo muchos negocios, todos los cuales fracasaron, perdiendo mucho dinero. ¿Cuál es la conducta más adecuada con este paciente?

a. Iniciar antidepresivos tricíclicos
b. Iniciar antidepresivos inhibidores de la recaptura de serotonina
c. Iniciar antidepresivos más antipsicóticos atípicos
d. Iniciar antidepresivos inhibidores de la monoaminoxidasa
e. Derivar a especialista

Respuesta correcta: e. Derivar a especialista

Explicación: Tiene una depresión, en contexto de un trastorno bipolar, por lo que están contraindicados todos los antidepresivos. Se tiene que tratar con estabilizadores del ánimo, como el litio, los anticonvulsivantes o los antipsicóticos atípicos. De las opciones, la única aceptable es derivar, pero

también habría sido correcto tratar con estabilizadores del ánimo, en especial con quetiapina, ya que el litio se usa más en la manía aguda que en la depresión bipolar.

Fuente: Psiquiatría, cuestionario 1.5, P11

Trastorno bipolar (6)

16. Usted evalúa a un paciente que es traído por sus familiares, ya que desde hace un mes está muy agresivo y raro. Refieren que está con ideas de hacer negocios y de inventar alguna empresa rápido, para aprovechar que tiene contactos con la presidencia de la república. Ha gastado mucho dinero en ropa elegante y accesorios para poder encajar bien en los nuevos grupos de poder y refiere que será muy exitoso. Cuando sus familiares le dicen que no están de acuerdo, se enoja, los insulta y dice que por culpa de ellos es que no ha podido aún lograr el éxito que quiere y que ya se aburrió de escuchar sus comentarios mediocres. El diagnóstico más probable es:

a. Trastorno bipolar
b. Trastorno delirante crónico megalomaníaco
c. Trastorno narcisista de la personalidad
d. Esquizofrenia
e. Intoxicación con cocaína

Respuesta correcta: a. Trastorno bipolar

Explicación: Parece un trastorno bipolar, con una manía severa. Además, al parecer está psicótico, con un delirio megalomaníaco (contactos en la presidencia e ideas de éxito). Sin embargo, la predominancia de síntomas anímicos (irritabilidad, enojo), así como la rápida evolución, hacen improbable un T. delirante crónico (debe ser mayor a 3 meses y avanza lentamente, comenzando por ideas raras, hasta que finalmente se establece el delirio).

Fuente: Psiquiatría, cuestionario 1.1, P8

17. Un paciente sufre una manía aguda, la que es contenida inicialmente con haloperidol y hospitalización. ¿Qué fármaco es más adecuado para lograr la remisión total del episodio y evitar recurrencias?

a. Haloperidol oral
b. Litio más aripiprazol
c. Fluoxetina
d. Moclobemida
e. Clorpromazina

Respuesta correcta: b. Litio más aripiprazol

Explicación: Tratamiento del trastorno bipolar (ha cambiado, ya que los antipsicóticos han demostrado ser muy buenos estabilizadores del ánimo, en especial, aripiprazol, risperidona, quetiapina y olanzapina): 1. Lo primero y más importante es que están contraindicados todos los antidepresivos. 2. El episodio agudo se trata con litio, anticonvulsivantes y/o antipsicóticos. - Manía aguda (2 fármacos): idealmente litio más antipsicótico. Aceptable valproato o carbamacepina más antipsicótico. Si está agitado y agresivo, de elección, haloperidol e incluso se puede mezclar con lorazepam. o Si falla, se cambia el litio o el ácido valproico, por el otro fármaco. o Si falla nuevamente, se cambia el antipsicótico (hasta dos veces). o De última línea, se indica TEC (terapia electroconvulsiva). - Hipomanía (1 fármaco): actualmente se recomiendan más los antipsicóticos que el litio o anticonvulsivantes, aunque cualquiera es una opción aceptable. Si falla, se trata como una manía. - Episodios mixtos y cicladores rápidos (4 o más episodios en

un año) actualmente se tratan igual que la manía (litio o valproato más antipsicóticos). - Depresión (1 fármaco): actualmente se recomiendan los antipsicóticos, en especial, quetiapina. Recordar que los antidepresivos están contraindicados. 3. Luego se indica terapia de mantención a permanencia: idealmente los mismos fármacos que lograron la remisión. Se cambian, si fallan. La lamotrigina se puede usar para prevenir nuevos episodios, pero no parece útil en el cuadro agudo.

Fuente: Psiquiatría, cuestionario 1.1, P18

18. Un paciente ingresa a la universidad, a estudiar derecho, con un buen puntaje en la PSU. Durante el primer mes está muy contento y les cuenta a todos sus amigos y familiares que será un excelente abogado y que de hecho ya está pensando en poner una empresa de consultoría para las grandes empresas del país. En ocasiones les cuenta sus planes a desconocidos y ha faltado a muchas clases por perder tiempo en trámites y averiguaciones, lo que le ha significado obtener bajas calificaciones, lo que él minimiza diciendo que esas notas las recuperará sin ningún problema porque "lleva el derecho en la sangre". Sus familiares se muestran preocupados, ya que lo encuentran raro. El diagnóstico más probable es:

a. Trastorno delirante crónico
b. Trastorno de personalidad narcisista
c. Trastorno bipolar
d. Esquizofrenia
e. Trastorno obsesivo compulsivo

Respuesta correcta: c. Trastorno bipolar

Explicación: Tiene una manía severa, probablemente psicótica. Orientan fuertemente a una manía las ideas de éxito, el optimismo y la verborrea que tiene, hablando incluso con desconocidos sobre sus planes. También la edad (suelen brotar a los 18 años en promedio). Si bien parece que tiene un delirio megalomaníaco, es secundario al cuadro anímico (a la manía). Por tanto, tiene un T. bipolar. El tratamiento agudo de la manía consiste en litio o ácido valproico más un antipsicótico (litio más risperidona es lo más usado). - Si falla, se cambia el litio o el ácido valproico, por el otro fármaco. - Si falla nuevamente, se cambia el antipsicótico (hasta dos veces)o - De última línea, se indica TEC (terapia electroconvulsiva).

Fuente: Psiquiatría, cuestionario 1.2, P2

19. Una paciente de 18 años, con depresión diagnosticada hace 13 días, en tratamiento con fluoxetina, presenta ánimo exaltado, verborrea, nuevas amistades, ideas de nuevos y exitosos negocios e involucración en problemas familiares llegando a presentar agresiones físicas contra sus hermanos. Actualmente se encuentra muy irritable y agresiva y se niega a ser tratada por el personal médico ya que según ella está en el mejor momento de su vida. El fármaco de elección en este momento es:

a. Litio
b. Haloperidol
c. Lorazepam
d. Fentanil
e. Morfina

Respuesta correcta: b. Haloperidol

Explicación: Tiene una manía aguda, desencadenada por los antidepresivos (basalmente tiene un trastorno bipolar, ya que es genético, que se manifestó como una depresión, la que, al ser tratada con antidepresivos, viró a manía). Por estar agitada y agresiva, en este momento, lo más urgente es la contención farmacológica, la que se hace con haloperidol 5 mg intramuscular, a menos que acepte

tomarlo oral, y luego una dosis de mantención. Luego, se iniciará el litio o el ácido valproico más algún antipsicótico (risperidona, olanzapina, aripiprazol o quetiapina tienen efectos antimaníaco y estabilizador del ánimo), para lograr la remisión completa del cuadro y evitar nuevos episodios maniacos y depresivos. La lamotrigina previene nuevos episodios, pero no ha demostrado ser útil en el episodio maníaco agudo.

Fuente: Psiquiatría, cuestionario 1.4, P7

20. Un paciente de 28 años afirma que es el alcalde del pueblo. Un mes atrás estaba completamente normal, sin embargo, empezó a dormir poco, leer mucho de política y opinar constantemente en las redes sociales. Le habla de política a todas las personas y ha realizado viajes a las sedes del partido que quedan en las ciudades aledañas. El cuadro fue empeorando, volviéndose agresivo y finalizando con la idea de que es el alcalde. El diagnóstico más probable es:

a. Trastorno delirante crónico
b. Esquizofrenia
c. Trastorno bipolar
d. Trastorno de personalidad narcisista
e. Trastorno de personalidad esquizoide

Respuesta correcta: c. Trastorno bipolar

Explicación: Tiene un delirio megalomaníaco, lo que hace pensar inicialmente en un T. delirante crónico. Sin embargo, la evolución demuestra que es una manía severa, que se volvió psicótica, ya que tiene la disminución de las necesidades de sueño, verborrea, agresividad, etc. Por tanto, su diagnóstico es un trastorno bipolar. El episodio agudo se trata con litio, anticonvulsivantes y/o antipsicóticos, idealmente litio más antipsicótico, siendo aceptable el valproato o carbamacepina más antipsicótico. Si está agitado y agresivo, de elección, haloperidol e incluso se puede mezclar con lorazepam. Si falla, se cambia el litio o el ácido valproico, por el otro fármaco. Si falla nuevamente, se cambia el antipsicótico (hasta dos veces). De última línea, se indica TEC (terapia electroconvulsiva).

Fuente: Psiquiatría, cuestionario 1.4, P12

21. Un paciente presenta un cuadro de 7 días de evolución caracterizado por ánimo irritable, "actitud rara" e insomnio. Al entrevistarlo habla mucho, cambia fácilmente de tema y deja inconclusas algunas ideas. Además, coquetea con la enfermera y refiere que es millonario y que pronto será billonario. El diagnóstico es:

a. Trastorno delirante crónico con delirio megalomaniaco
b. Trastorno bipolar en episodio maníaco
c. Trastorno de personalidad narcisista
d. Trastorno de personalidad histriónico
e. Esquizofrenia

Respuesta correcta: b. Trastorno bipolar en episodio maníaco

Explicación: Tiene un trastorno bipolar, con episodio maníaco clásico: irritabilidad, verborrea, fuga de ideas, disminución del sueño, ideas de grandiosidad y éxito y desinhibición. En agudo, el tratamiento es con litio o ácido valproico más antipsicóticos (risperidona, olanzapina, aripiprazol o quetiapina). Luego, queda con tratamiento de mantención (generalmente el mismo que logró la remisión).

Fuente: Psiquiatría, cuestionario 1.5, P13

Esquizofrenia y psicosis (6)

22. ¿Cuál es el tratamiento más adecuado para un paciente con un cuadro cónico de alucinaciones auditivas, asociada a un delirio místico-religioso?

a. Litio
b. Risperidona
c. Antipsicóticos de depósito
d. Antidepresivos
e. Benzodiacepinas

Respuesta correcta: b. Risperidona

Explicación: Tiene una esquizofrenia clásica. El tratamiento de la esquizofrenia se puede resumir en: Antipsicóticos orales más psicoterapia y psicoeducación. Generalmente se indica risperidona o aripiprazol en la menor dosis posible, que mantiene al paciente sin síntomas. - Si responde parcialmente, se debe subir la dosis. Pero, si no adhiere bien al tratamiento, se debe cambiar a un antipsicótico de depósito (ej. modecate). - Si produce efectos adversos, se debe cambiar a otros antipsicótico. Si vuelve a tener efectos adversos o ideación suicida persistente, se indica la clozapina. El tratamiento se debe Se debe mantener por mínimo 2 a 3 años, antes de intentar retirarlos cuidadosamente (bajando dosis lentamente y monitorizando los síntomas con frecuencia). Los síntomas negativos son muy difíciles de tratar, pero, probablemente responden más a los antipsicóticos atípicos o de segunda generación. La esquizofrenia simple (solo síntomas negativos) o esquizofrenia deficitaria (síntomas negativos muy marcados) suelen tener un pronóstico más pobre.

Fuente: Psiquiatría, cuestionario 1.1, P14

23. Las alucinaciones de la esquizofrenia son característicamente:

a. Visuales personificadas
b. Visuales no personificadas
c. Auditivas personificadas
d. Auditivas no personificadas
e. Complejas, con componentes visuales y auditivos personificados y no personificados

Respuesta correcta: c. Auditivas personificadas

Explicación: Suelen escuchar voces, por lo que son alucinaciones auditivas y personificadas. Un ejemplo de una alucinación auditiva no personificada sería escuchar explosiones o música. Vale la pena mencionar que pueden tener todo tipo de alucinaciones (visuales, cenestésicas, etc.).

Fuente: Psiquiatría, cuestionario 1.2, P5

24. La esquizofrenia simple se caracteriza por:

a. Predominancia de síntomas negativos
b. Presencia de delirio paranoide
c. Presencia de alucinaciones sin pérdida del juicio de la realidad
d. presencia de delirio sistematizado
e. Ausencia de trastornos de personalidad y trastornos anímicos sobreagregado

Respuesta correcta: a. Predominancia de síntomas negativos

Explicación: La esquizofrenia simple es aquella que solo tienen síntomas negativos, también llamados primarios o deficitarios (aplanamiento afectivo, apatía, abulia, ineficiencia en el trabajo ejecutivo), sin

síntomas positivos, también llamados secundarios o productivos (alucinaciones y delirios). Los síntomas negativos son muy difíciles de tratar, pero, probablemente responden más a los antipsicóticos atípicos o de segunda generación. Por ello, la esquizofrenia simple (solo síntomas negativos) y la esquizofrenia deficitaria (síntomas negativos muy marcados) suelen tener un pronóstico más pobre.

Fuente: Psiquiatría, cuestionario 1.2, P14

25. Una paciente de 30 años refiere que los espíritus le hablan y le dicen que se suicide. Es muy apática y afectivamente plana y tiene la idea de que el Diablo vive dentro de ella. El fármaco más adecuado para el manejo crónico de esta paciente es:

a. Sertralina
b. Litio
c. Risperidona
d. Lamotrigina
e. Diazepam

Respuesta correcta: c. Risperidona

Explicación: Tiene una esquizofrenia paranoide clásica: alucinaciones auditivas, delirio paranoide/religioso y síntomas negativos (apatía y aplanamiento afectivo). Se trata con antipsicóticos atípicos, como la risperidona o el aripiprazol. · Si responde parcialmente, se debe subir la dosis. Pero, si no adhiere bien al tratamiento, se debe cambiar a un antipsicótico de depósito (ej. modecate: flufenazina; aunque actualmente también hay antipsicóticos de segunda generación de larga duración, como risperidona o aripiprazol). · Si produce efectos adversos, se debe cambiar a otros antipsicótico. Si vuelve a tener efectos adversos o ideación suicida persistente, se indica la clozapina. El tratamiento se debe Se debe mantener por mínimo 2 a 3 años, antes de intentar retirarlos cuidadosamente (bajando dosis lentamente y monitorizando los síntomas con frecuencia). Los síntomas negativos son muy difíciles de tratar, pero, probablemente responden más a los antipsicóticos atípicos o de segunda generación. La esquizofrenia simple (solo síntomas negativos) o esquizofrenia deficitaria (síntomas negativos muy marcados) suelen tener un pronóstico más pobre.

Fuente: Psiquiatría, cuestionario 1.3, P17

26. Paciente de 30 años, refiere que es el hijo de Dios, por lo que ha establecido una forma de vida para satisfacer las necesidades de su padre para la salvación de la humanidad, formando un grupo que lo apoya en su idea con ofrendas y sacrificios para evitar la extinción de la humanidad. Al intentar hablar con el paciente y exponerle su verdadera identidad como una persona normal, él reacciona con ira y no acepta este hecho. El diagnóstico más probable es:

a. Delirio
b. Delirium
c. Trastorno de personalidad
d. Trastorno obsesivo compulsivo
e. Trastorno bipolar

Respuesta correcta: a. Delirio

Explicación: Tiene un delirio de tipo megalomaníaco. Su reacción deja claro que está psicótico. No se debe confundir con delirium, que es el síndrome confusional agudo. No se entrega suficiente información como para saber la causa del delirio (ej. esquizofrenia, asociado a drogas o incluso un trastorno delirante crónico, sobre alguna otra patología psiquiátrica de base).

Fuente: Psiquiatría, cuestionario 1.4, P11

27. La característica más importante de la esquizofrenia es:

a. Presencia de delirio sistematizado
b. Imposibilidad o dificultad para diferenciar la realidad interna de la realidad externa
c. Presencia de agitación psicomotora
d. Presencia de síntomas motores como rigidez cérea
e. Presencia de alucinaciones

Respuesta correcta: b. Imposibilidad o dificultad para diferenciar la realidad interna de la realidad externa

Explicación: La imposibilidad de diferenciar la realidad interna (sus propios pensamientos), de la realidad externa (la realidad), es la característica más importante de la esquizofrenia. El delirio sistematizado es propio del T. delirante crónico. La agitación psicomotora puedo o no estar, pero también se ve en todas ls patologías psiquiátricas descompensadas. Los síntomas motores son específicos de la esquizofrenia catatónica. Las alucinaciones son muy comunes en la esquizofrenia, pero no están siempre y se pueden dar en otros cuadros psicóticos.

Fuente: Psiquiatría, cuestionario 1.5, P9

Trastorno delirante crónico (5)

28. Un paciente de 58 años refiere que es espiado por la CIA a través de satélites e intercepciones de sus llamadas telefónicas. Por eso ya no usa el celular y usa sombrero cada vez que debe hacer algo que él considere importante, de modo de no ser reconocido por los satélites. Empezó con esta idea hace un año, luego de ver un reportaje que mostraba la tecnología satelital y la calidad con la que podía ver la superficie terrestre. A parte de esto, se desempeña normalmente en su trabajo y nunca ha sufrido alucinaciones. El diagnóstico más probable es:

a. Trastorno de personalidad esquizotípico
b. Trastorno de personalidad paranoide
c. Trastorno delirante crónico
d. Esquizofrenia
e. Trastorno obsesivo compulsivo

Respuesta correcta: c. Trastorno delirante crónico

Explicación: Tiene un delirio paranoide, mayor a 3 meses, que no afecta otras áreas de su vida, por lo que es un T. delirante crónico clásico (si lleva más de 4 semanas, pero menos de 3 meses, se llama solo "trastorno delirante", sin la palabra "crónico"). El tratamiento consiste en antipsicóticos atípicos (aripiprazol o risperidona) más psicoterapia, aunque muchas veces es difícil convercer al paciente de tomarlos. - La esquizofrenia sería en un paciente más joven, con alucinaciones y síntomas negativos (abulia, aplanamiento afectivo, apatía). - Los trastornos de personalidad no tienen delirios (no están psicóticos), sino solo son una forma de ser patológica (ej. el T. personalidad paranoide es demasiado desconfiado, pero no está psicótico). Eso sí, se pueden complicar con un trastorno delirante.

Fuente: Psiquiatría, cuestionario 1.1, P3

29. Un paciente de 60 años refiere ser la rencarnación del verdadero Dalai Lama. Lleva una vida muy tranquila, con meditación y practicando las enseñanzas del budismo. Al ser interrogado, cuenta que siempre ha sido muy religioso y cercano a la naturaleza y animales y desde hace 5 años empezó a soñar que él era el Dalai Lama y que vivía en los Himalayas. Al averiguar más notó que el Dalai Lama mundialmente reconocido era un impostor y que había manipulado a todos, sin embargo, él no le guarda

rencor y dice que desde el anonimato sigue luchando por la purificación del mundo. Al decirle que es muy difícil creer que él sea realmente dicho personaje, él responde: “Doctor, lamento que aún no pueda ver lo que yo ahora veo, pero su mente aún está nublada por los pensamientos terrenales y sólo con meditación y desapego de lo material, logrará comprender”. El diagnóstico más probable es:

a. Esquizofrenia
b. Manía
c. Episodio mixto
d. Trastorno delirante crónico
e. Trastorno de personalidad esquizotípico

Respuesta correcta: d. Trastorno delirante crónico

Explicación: Tiene un delirio megalomaníaco. Además, es un delirio sistematizado, ya que es capaz de explicarlo claramente. No tiene síntomas anímicos (exaltación del ánimo, verborrea, hiperactividad, disminución de la necesidad de dormir, etc.) como para pensar en un T. bipolar con manía o episodio mixto. Tampoco tiene síntomas negativos ni alucinaciones, como para pensar en una esquizofrenia. Por tanto, es un T. delirante crónico clásico.

Fuente: Psiquiatría, cuestionario 1.2, P11

30. Un paciente de 46 años refiere estar casado con la Presidente de su país. Cuenta que desde que la conoció por televisión la encontró muy buena moza y que compartía sus convicciones políticas, por lo que empezó a participar activamente en su campaña y la conoció un día que ella dio un discurso. Desde entonces, se ha dado cuenta que los discurso que da, vienen con mensajes subliminales hacia él, (por ejemplo, en una ocasión las primeras letras de las palabras de una frase que dijo (“ahora mis oportunidades serán para ellos”) significaban AMO y luego SPE, que son sus iniciales. Finalmente, al momento de las elecciones, él votó por ella, pero ese acto fue mucho más que eso, ya que en realidad estaba aceptando ser su esposo. Al confrontarlo y decirle que la presidenta pareciera no estar interesada en él, afirma que es culpa de los partidos políticos, que no la dejan estar con él, porque bajaría su popularidad, pero que él es la razón por la cual no tiene otra pareja. El diagnóstico más probable es:

a. Trastorno delirante crónico
b. Trastorno de personalidad narcisista
c. Trastorno de personalidad histriónico
d. Trastorno bipolar
e. Esquizofrenia

Respuesta correcta: a. Trastorno delirante crónico

Explicación: Tiene un delirio erotomaníaco, muy bien explicado, por lo que es un delirio sistematizado, característico del T. delirante crónico (delirio sistematizado, mayor a 3 meses, sin mucha afectación del resto de la vida). Además, al confrontarlo con la realidad, demuestra estar psicótico. No tiene síntomas anímicos (exaltación del ánimo, verborrea, hiperactividad, etc.), como para pensar en un trastorno bipolar. No tiene alucinaciones ni síntomas negativos, como para pensar en esquizofrenia. Finalmente, los trastornos de personalidad, por regla general no tienen psicosis, es decir, conservan el juicio de realidad.

Fuente: Psiquiatría, cuestionario 1.3, P6

31. Un paciente de 56 años refiere que hay un complot del gobierno ruso, en contra de él. Por eso le instalaron un virus en su computador, de modo de espiarlo y robarle sus datos personales y bancarios. Explica que los rusos creen que él es un espía o algo similar, ya que en internet encontró información sobre el modelo económico ruso y comentó por las redes sociales que debía cambiar. Como prueba de

esto, refiere que instaló un antivirus, que encontró 2 archivos infectados y que recibe spam en ruso. El diagnóstico más probable es:

a. Esquizofrenia
b. Trastorno delirante crónico
c. Trastorno bipolar en fase maníaca
d. Trastorno de personalidad esquizoide
e. Trastorno de personalidad paranoide

Respuesta correcta: b. Trastorno delirante crónico

Explicación: Tiene un trastorno delirante crónico clásico, con presencia de un delirio sistematizado (bien explicado), de tipo paranoide. No tiene alucinaciones ni síntomas negativos, como para pensar en esquizofrenia. Además, sería muy raro que una esquizofrenia brotara recién a los 56 años. Los trastornos de personalidad no están psicóticos (este paciente sí lo está), sino que simplemente son una forma de ser patológica, que acarrea malas relaciones interpersonales.

Fuente: Psiquiatría, cuestionario 1.3, P12

32. Un paciente de 59 años está convencido que su hijo lo odia y que por eso siempre hace comentarios para humillarlo frente a sus familiares e incluso con otras personas. Explica que su hijo lo desprecia y que se cree superior por haber obtenido un título profesional, mientras que el paciente sólo terminó la educación media. Su mujer y sus hijos, incluyendo al hijo en cuestión, niegan la situación y se muestran muy preocupados por el paciente. El diagnóstico más probable es:

a. Depresión psicótica
b. Esquizofrenia
c. Trastorno de personalidad paranoide
d. Trastorno delirante crónico
e. Trastorno bipolar

Respuesta correcta: d. Trastorno delirante crónico

Explicación: Tiene un delirio de daño (“alguien me odia y quiere dañarme”). Probablemente tiene un trastorno delirante crónico, por la edad y por la forma en que explica sus ideas. No tiene alucinaciones ni síntomas negativos, como para pensar en esquizofrenia (además de la edad). Se trata con antipsicóticos orales de segunda generación (risperidona, aripiprazol) y psicoterapia. Sin embargo, suele ser difícil convencer al paciente de seguir el tratamiento.

Fuente: Psiquiatría, cuestionario 1.5, P12

Trastornos de ansiedad (11)

33. Un paciente se pone muy ansioso en situaciones en las que debe actuar en público, como hablar en público, exponer frente a sus compañeros de curso y profesores e incluso comer frente a los demás. Además, ha presentado crisis de pánico antes de las presentaciones y exámenes orales. El diagnóstico más probable es:

a. Fobia específica
b. Trastorno de personalidad evitativo
c. Trastorno de personalidad dependiente
d. Trastorno de pánico con agorafobia
e. Fobia social

Respuesta correcta: e. Fobia social

Explicación: Es una fobia social clásica, también llamada trastorno de ansiedad social. Se caracteriza por ansiedad ante el juicio o escrutinio público. Existen dos tipos de trastorno por ansiedad social: 1. Ansiedad social generalizada (o simplemente, ansiedad social) y 2. Ansiedad social específica ante performance (suele responder a la psicoterapia sola). El tratamiento suele ser con psicoterapia específica (ej. exposición a situaciones similares y manejo). En casos más graves, se requieren fármacos (IRS o venlafaxina, al igual que en todos los trastornos ansiosos). En casos graves, las benzodiacepinas pueden ser de utilidad como tratamiento sintomático en momentos específicos, al igual que el propanolol (disminuye palpitaciones y temblor).

Fuente: Psiquiatría, cuestionario 1.1, P2

34. Una mujer de 46 años es muy ansiosa y sale muy poco de su casa, ya que le puede pasar algo malo. Cuenta que hace 5 años estuvieron a punto de atropellarla, pero que, gracias a Dios, salvó ilesa. Además, les pide a sus hijos que tengan mucho cuidado, que no anden en bus y que manejen lento para que no les pase nada y que por ningún motivo saquen a sus nietos de la casa, porque puede sufrir un accidente o contraer una enfermedad grave. El diagnóstico más probable es:

a. Trastorno de ansiedad
b. Trastorno agorafóbico
c. Trastorno de personalidad evitativo
d. Trastorno de estrés postraumático
e. Trastorno de ansiedad generalizada

Respuesta correcta: e. Trastorno de ansiedad generalizada

Explicación: Es un T. ansiedad generalizada clásico, que se caracteriza por expectación ansiosa: ansiedad ante múltiples hechos que pueden ocurrir, con marcadas conductas evitativas. No tiene crisis de pánico, por lo que no puede ser un T. de ansiedad. No está relacionada a la falta de ayuda y además tiene ansiedad frente a hechos relativos a otras personas, por lo que no puede ser agorafobia. No tiene reexperimentación del accidente, por lo que no puede ser un TEPT.

Fuente: Psiquiatría, cuestionario 1.1, P10

35. ¿Cuál de las siguientes patologías es parte del diagnóstico diferencial del trastorno de pánico y puede ser confundida con este?

a. Trastorno de personalidad evitativo
b. Déficit de vitamina B12
c. Hipotiroidismo
d. Trastorno de ansiedad generalizada
e. Taquicardia paroxística supraventricular

Respuesta correcta: e. Taquicardia paroxística supraventricular

Explicación: El T. de pánico o T. de ansiedad, se caracteriza por crisis de pánico recurrentes, sin una causa clara. Por eso, dentro del diagnóstico diferencial, están el hipertiroidismo, el feocromocitoma y las arritmias paroxísticas, como la TPSV y la FA paroxística.

Fuente: Psiquiatría, cuestionario 1.1, P12

36. Una mujer de 29 años presenta una crisis de pánico mientras estaba en la calle, comprando. Presenta mucha ansiedad y ha presentado cerca de 10 crisis de pánico en las últimas 6 semanas, algunas de ellas

sin un desencadenante claro. Además, refiere miedo a le dé una crisis grave en la que muera y que nadie la ayude, por eso es que evita salir de su casa y sólo lo hace acompañada. El diagnóstico más probable es:

a. Trastorno de pánico sin agorafobia
b. Trastorno de pánico con agorafobia
c. Trastorno de ansiedad generalizada
d. Fobia social
e. Agorafobia aislada

Respuesta correcta: b. Trastorno de pánico con agorafobia

Explicación: Tiene un trastorno de pánico clásico: crisis de pánico recurrentes, sin un desencadenante claro (aunque el paciente los relacione indirectamente con un evento), asociado a miedo a tener nuevas crisis. Además, tiene las conductas evitativas clásicas. Es frecuente que se asocie a agorafobia (miedo a no recibir ayuda), lo que se ve claramente en este caso (no sale sola, pero sí acompañada). De hecho, el T. ansiedad (angustia o pánico) se clasifica en con y sin agorafobia. Si en las alternativas los obligaran a elegir entre agorafobia y T. ansiedad, habría que marcar este último.

Fuente: Psiquiatría, cuestionario 1.2, P9

37. ¿Cuál es el tratamiento más adecuado para una paciente de 50 años con un trastorno de ansiedad generalizada?

a. Benzodiacepinas de acción larga
b. Benzodiacepinas de acción corta
c. Antidepresivos
d. Antipsicóticos típicos
e. Antipsicóticos atípicos

Respuesta correcta: c. Antidepresivos

Explicación: Los trastornos ansiosos crónicos, incluyendo el TAG, se tratan preferentemente con antidepresivos IRS. Además, se le pueden agregar benzodiazepinas como tratamiento sintomático, pero estas no son el tratamiento de elección y solo se indican al inicio del tratamiento.

Fuente: Psiquiatría, cuestionario 1.2, P10

38. El trastorno de pánico se caracteriza principalmente por:

a. Ansiedad frente a lo desconocido
b. Expectación ansiosa
c. Crisis de pánico recurrentes
d. Miedo a no recibir ayuda
e. Miedo intenso y constante

Respuesta correcta: c. Crisis de pánico recurrentes

Explicación: El trastorno de angustia se caracteriza por crisis de pánico recurrentes, sin un gatillante claro y por miedo a dichas crisis (morirse, volverse loco, sufrir un infarto, etc., durante ellas). La ansiedad frente a lo desconocido es normal. La expectación ansiosa es característica del trastorno de angustia generalizada (TAG). El miedo a no recibir ayuda es característico de la agorafobia, la que puede acompañar al trastorno de angustia, o bien presentarse aislada. El miedo intenso y constante no es propio de ninguna enfermedad, pero podría sugerir más un TAG, dado lo constante.

Fuente: Psiquiatría, cuestionario 1.3, P3

39. Paciente de 32 años, sin antecedentes, consulta por episodios de palpitaciones, sudoración, temblor de extremidades y gran sensación de angustia; síntomas duran aproximadamente 10 minutos. Ha presentado estos episodios en 5 ocasiones durante el último mes, sin presentar un desencadenante claro, por lo cual ha estado bastante ansiosa. El diagnóstico más probable es:

a. Trastorno de ansiedad
b. Trastorno de angustia generalizada
c. Agorafobia
d. Trastorno conversivo
e. Trastorno de personalidad

Respuesta correcta: a. Trastorno de ansiedad

Explicación: Es un trastorno de ansiedad clásico: crisis de pánico recurrentes, sin gatillante claro. El TAG tiene expectación ansiosa (miedo a que algo malo pase), sin crisis de pánico y con mucha evitación. La agorafobia se caracteriza por miedo a sufrir algo y no recibir ayuda.

Fuente: Psiquiatría, cuestionario 1.4, P1

40. Paciente de 18 años sin antecedentes, consulta por presentar gran nerviosismo cuando se presenta ante un grupo social ya que tartamudea, lo cual le causa gran angustia ya que cree que pensarán cosas malas de él. Esto mismo le ocurría en el colegio cuando le tocaba disertar, llegando incluso a presentar una crisis de pánico en una ocasión. El diagnóstico más probable es:

a. Trastorno de ansiedad generalizada
b. Trastorno de personalidad evitativo
c. Trastorno de angustia
d. Fobia social
e. Fobia específica

Respuesta correcta: d. Fobia social

Explicación: Tiene una fobia social o ansiedad social clásica: angustia al estar en situaciones en que se somete al juicio o escrutinio de los demás, como exponer o disertar. Falta información como para descartar un trastorno de personalidad evitativo, que se caracteriza por baja autoestima y evitación de situaciones en que estará con otros, por miedo al rechazo. Sin embargo, la pregunta está redactada en términos que hacen más probable la fobia social. Existen dos tipos de trastorno por ansiedad social: 1. Ansiedad social generalizada (o simplemente, ansiedad social) y 2. Ansiedad social específica ante performance (suele responder a la psicoterapia sola). El tratamiento suele ser con psicoterapia específica (ej. exposición a situaciones similares y manejo). En casos más graves, se requieren fármacos (IRS o venlafaxina, al igual que en todos los trastornos ansiosos). Las benzodiacepinas pueden ser de utilidad como tratamiento sintomático en momentos específicos, al igual que el propanolol (disminuye palpitaciones y temblor).

Fuente: Psiquiatría, cuestionario 1.4, P3

41. Una paciente de 53 años, consulta porque se siente angustiada. Tiene la sensación de que algo malo puede pasarle, como un asalto o un accidente, por lo que ya casi no sale de su casa, lo que limita sus actividades diarias. Además, tiene miedo a que algo malo le pase a sus hijos y que haya una catástrofe natural. Cuando ve las noticias, se angustia mucho, ya que teme que le pases esas cosas a ella o a sus familiares. El tratamiento más adecuado de esta patología es:

a. Benzodiacepinas

b. Antidepresivos
c. Antipsicóticos atípicos
d. Antipsicóticos típicos
e. Anticonvulsivantes

Respuesta correcta: b. Antidepresivos

Explicación: Tiene un trastorno de ansiedad generalizado clásico. El TAG, al igual que los demás trastornos ansiosos crónicos se tratan con psicoterapia y/o antidepresivos IRS. Al inicio, se le pueden dar benzodiacepinas, como tratamiento sintomático, pero lo más importante son los antidepresivos.

Fuente: Psiquiatría, cuestionario 1.4, P6

42. Una paciente de 29 años presentó un episodio caracterizado por miedo, llanto, angustia, dificultad para respirar y parestesias en las manos, mientras iba manejando, por lo que tuvo que detenerse a un lado de la carretera. El cuadro comenzó con angustia leve, pero empeoró en los 5 minutos siguientes, durando cerca de 20 minutos en total. En cuatro oportunidades posteriores sufrió lo mismo, especialmente al recordar el episodio. Consulta muy asustado por esto. El diagnóstico más probable es:

a. Agorafobia
b. Trastorno de ansiedad
c. Trastorno de ansiedad generalizada
d. Trastorno fóbico situacional
e. Trastorno conversivo

Respuesta correcta: b. Trastorno de ansiedad

Explicación: Tiene un T. de ansiedad clásico, ya que tuvo una crisis de pánico (el cuadro descrito: angustia y síntomas de todo tipo que aparecen en menos de 10 minutos) y luego tuvo más crisis de pánico sin un desencadenante claro. El tratamiento consiste en psicoterapia y/o IRS. Para las crisis, se puede indicar benzodiacepinas.

Fuente: Psiquiatría, cuestionario 1.5, P10

43. El tratamiento de elección del trastorno de angustia es:

a. Antipsicóticos típicos
b. Estabilizadores del ánimo
c. Antidepresivos
d. Benzodiacepinas
e. Antipsicóticos atípicos

Respuesta correcta: c. Antidepresivos

Explicación: El T. de angustia, al igual que todos los trastornos ansiosos crónicos, se tratan preferentemente con psicoterapia y/o antidepresivos IRS. Por regla general, se usa la misma dosis que en la depresión, solo que se inicia con dosis más bajas y se va subiendo de a poco (porque al inicio los IRS pueden tener un efecto ansiogénico). Al inicio sí se pueden dar las benzodiacepinas, como tratamiento sintomático, pero se deben tratar de suspender en el corto plazo. Lo más importante son los IRS, al menos en nuestro medio.

Fuente: Psiquiatría, cuestionario 1.5, P19

Trastorno obsesivo compulsivo (5)

44. Usted evalúa a un paciente que está muy preocupado y angustiado, porque teme estar volviéndose loco. Dice que tiene la idea de que su casa será robada por delincuentes y que él dejó la puerta abierta. Por eso se tiene que devolver a cerciorarse de haber puesto llave y que incluso lo ha hecho después de haber ido ya en dos oportunidades. El diagnóstico más probable es:

a. Trastorno de personalidad obsesiva compulsiva
b. Trastorno obsesivo compulsivo
c. Trastorno delirante crónico
d. Trastorno de estrés postraumático
e. Trastorno de angustia generalizada

Respuesta correcta: b. Trastorno obsesivo compulsivo

Explicación: Tiene un TOC clásico, con obsesión de duda y de robo y compulsión de corroboración. El T. personalidad TOC, en cambio, es una persona con muchos rituales y preocupación por los detalles, pero egosintónica, es decir, conforme con sus acciones y molesta con las acciones de los demás. El tratamiento del TOC incluye psicoterapia (generalmente cognitivo conductual de exposición y prevención de respuesta) y/o antidepresivos IRS (al igual que todos los trastornos ansiosos). El sí, los IRS suelen requerir una dosis relativamente alta (ej. fluoxentina 40 a 80 mg/día). Como alternativas, sirve la clomipramina (tricíclico) y la venlafaxina (dual), ambos también con efectos sobre la serotonina (inhiben recaptura de serotonina y norepinefrina). En los casos refractarios, se puede agregar una dosis baja de antipsicóticos atípicos (ej. risperidona o quetiapina), ya que tienen un efecto anti impulsivo.

Fuente: Psiquiatría, cuestionario 1.1, P15

45. Un paciente de 35 años consulta muy angustiado, porque desde hace 3 meses presenta la idea de que él agredirá a las personas que se le cruzan en la calle, por eso sale poco de su casa y además cruza la calle cada vez que alguien se le acerca. Al preguntarle si está seguro de que realmente golpeará a la persona, él responde: “No estoy 100% seguro, pero no me voy a arriesgar”. El diagnóstico más probable es:

a. Esquizofrenia paranoide
b. Trastorno delirante crónico
c. Trastorno obsesivo compulsivo
d. Trastorno de personalidad limítrofe
e. Trastorno bipolar

Respuesta correcta: c. Trastorno obsesivo compulsivo

Explicación: Tiene un TOC clásico, con obsesión de conducta impropia (conductas agresivas o sexuales son las más frecuentes) y compulsiones de evitación (cruzar la calle, no salir). La frase “no estoy seguro” apunta a que no está psicótico, sino que es un trastorno neurótico. El tratamiento del TOC incluye psicoterapia (generalmente cognitivo conductual de exposición y prevención de respuesta) y/o antidepresivos IRS (al igual que todos los trastornos ansiosos). El sí, los IRS suelen requerir una dosis relativamente alta (ej. fluoxentina 40 a 80 mg/día). Como alternativas, sirve la clomipramina (tricíclico) y la venlafaxina (dual), ambos también con efectos sobre la serotonina (inhiben recaptura de serotonina y norepinefrina). En los casos refractarios, se puede agregar una dosis baja de antipsicóticos atípicos (ej. risperidona o quetiapina), ya que tienen un efecto anti impulsivo.

Fuente: Psiquiatría, cuestionario 1.2, P16 · Psiquiatría, cuestionario 1.5, P3

46. Un paciente tiene la idea de que algo malo le va a suceder o que Dios lo va a castigar, cuando escucha a alguien decir alguna grosería. Para evitar esto, repite en su mente varias veces la frase "Dios no lo escuches". En el último tiempo esto ha empeorado, ya que, al escuchar otras palabras negativas, como "malo", "robo" o incluso "no", le sucede lo mismo. Esto lo tiene muy angustiado, piensa gran parte del día en eso y sabe que no es normal. El tratamiento más adecuado es:

a. Antipsicóticos atípicos
b. Antipsicóticos típicos
c. Antidepresivos IRSS
d. Antidepresivos tricíclicos
e. Anticonvulsivantes

Respuesta correcta: c. Antidepresivos IRSS

Explicación: Es un TOC clásico, con obsesión de tipo religioso y una compulsión de tipo mental. Las obsesiones siempre son mentales, ya que son ideas que generan ansiedad. Las compulsiones son generalmente externas, pero también pueden ser mentales (repetir mentalmente palabras, rezar, etc.), aunque se diferencian de la obsesión, en que estas compulsiones disipan la ansiedad, mientras que las obsesiones la generan. El tratamiento del TOC incluye psicoterapia (generalmente cognitivo conductual de exposición y prevención de respuesta) y/o antidepresivos IRS (de elección, al igual que todos los trastornos ansiosos). El sí, los IRS suelen requerir una dosis relativamente alta (ej. fluoxentina 40 a 80 mg/día). Como alternativas, sirve la clomipramina (tricíclico) y la venlafaxina (dual), ambos también con efectos sobre la serotonina (inhiben recaptura de serotonina y norepinefrina). En los casos refractarios, se puede agregar una dosis baja de antipsicóticos atípicos (ej. risperidona o quetiapina), ya que tienen un efecto anti impulsivo.

Fuente: Psiquiatría, cuestionario 1.3, P2

47. Paciente de 32 años, consulta muy preocupado porque desde hace algunos meses tiene la idea de que su mano izquierda no es de él, por esto debe tocarse esa mano con la otra, llegando incluso después realizar esta acción en varias ocasiones seguidas. El teme estar volviéndose loco ya que cuando se toca la mano se queda tranquilo, pero no encuentra normal que esto le pase tan seguido. Al preguntarle dirigidamente, refiere que sí sabe que es su mano, pero que no puede evitar tener esa idea. El diagnóstico más probable es:

a. Trastorno obsesivo compulsivo
b. Trastorno delirante crónico
c. Trastorno de la personalidad obsesivo compulsivo
d. Trastorno dismórfico corporal
e. Trastorno disociativo

Respuesta correcta: a. Trastorno obsesivo compulsivo

Explicación: Es un cuadro difícil. Sin embargo, tiene una obsesión (idea que le genera ansiedad): "la mano no es mía" y una compulsión (acción que disipa su ansiedad): se toca la mano. Por tanto, tiene un TOC. Si simplemente sintiera que su mano no es de él, sería un T. disociativo por despersonalización. Si sintiera que su mano es horrible, tendría un T. dismórfico corporal.

Fuente: Psiquiatría, cuestionario 1.4, P2

48. El tratamiento de elección del trastorno obsesivo compulsivo es:

a. Antipsicóticos típicos

b. Estabilizadores del ánimo
c. Antidepresivos
d. Benzodiacepinas
e. Antipsicóticos atípicos

Respuesta correcta: c. Antidepresivos

Explicación: El tratamiento del TOC incluye psicoterapia (generalmente cognitivo conductual de exposición y prevención de respuesta) y/o antidepresivos IRS (al igual que todos los trastornos ansiosos). El sí, los IRS suelen requerir una dosis relativamente alta (ej. fluoxentina 40 a 80 mg/día). Como alternativas, sirve la clomipramina (tricíclico) y la venlafaxina (dual), ambos también con efectos sobre la serotonina (inhiben recaptura de serotonina y norepinefrina). En los casos refractarios, se puede agregar una dosis baja de antipsicóticos atípicos (ej. risperidona o quetiapina), ya que tienen un efecto anti impulsivo.

Fuente: Psiquiatría, cuestionario 1.5, P17

Trastornos relacionados con el estrés (5)

49. Un paciente es asaltado por dos delincuentes, quienes lo patean en el suelo. Durante la semana siguiente presenta angustia y recuerdos del hecho, asociados a pesadillas muy desagradables. Además, evita andar en la calle solo y se sobresalta fácilmente por cualquier ruido. El diagnóstico más probable es:

a. Trastorno de estrés postraumático
b. Trastorno de estrés agudo
c. Trastorno adaptativo
d. Trastorno de angustia
e. Reacción normal

Respuesta correcta: b. Trastorno de estrés agudo

Explicación: Es un trastorno de estrés clásico (evento crítico, seguido de reexperimentación, angustia, evitación e hiperalerta). Por tener menos de 4 semanas, es un trastorno de estrés agudo. Si tuviese más de 4 semanas, sería postraumático.

Fuente: Psiquiatría, cuestionario 1.1, P1

50. Un paciente presenció un accidente de tránsito en que un motociclista fue arrollado por un camión, muriendo al instante, de manera muy cruenta. Dos meses después empieza con recuerdos y pesadillas con el suceso, los que son muy desagradables y le causan mucha ansiedad, llegando incluso a presentar crisis de ansiedad en 2 oportunidades. Refiere que pequeños ruidos lo asustan y se sobresalta fácilmente cuando alguien toca la bocina o frena brusco, por lo que evita manejar. El tratamiento de la patología descrita es:

a. Antidepresivos y psicoterapia
b. Antipsicóticos y psicoterapia
c. Anticonvulsivantes y psicoterapia
d. Benzodiacepinas y psicoterapia
e. Psicoterapia sola

Respuesta correcta: a. Antidepresivos y psicoterapia

Explicación: Tiene un trastorno de estrés postraumático (TEPT). Como todos los trastornos ansiosos crónicos, se trata preferentemente con antidepresivos IRS. Además, se puede dar benzodiacepinas al

inicio, pero no son el tratamiento más importante, sino solo sintomático. La psicoterapia se indica en todos los trastornos psiquiátricos.

Fuente: Psiquiatría, cuestionario 1.2, P20

51. Un paciente de 34 años consulta por un cuadro de un mes de evolución de insomnio, ánimo bajo y angustia, relacionado con recuerdos y pesadillas sobre el incendio de su casa, que sucedió 3 meses antes. Evita hablar del tema y se siente muy incómodo en presencia de fuego, incluso de una simple vela. Ante pequeños estímulos, como crujidos u olor a humo se acuerda inmediatamente del incendio y va a verificar si hay fuego en alguna parte de su nueva casa. El diagnóstico más probable es:

a. Depresión
b. Trastorno adaptativo
c. Trastorno obsesivo compulsivo
d. Trastorno de estrés postraumático
e. Trastorno de angustia

Respuesta correcta: d. Trastorno de estrés postraumático

Explicación: Tiene un trastorno de estrés postraumático (TEPT) clásico: evento que amenaza la vida propia o de los demás y que luego evoluciona con reexperimentación (recuerdos o pesadillas), hiperalerta (sobresalta con pequeños estímulos), evitación y embotamiento afectivo (dificultad para expresar sus sentimientos). Si lleva menos de 4 semanas es un T. estrés agudo. Si lleva más, es un TEPT. El tratamiento del TEPT incluye psicoterapia enfocada en trauma y/o antidepresivos IRS.

Fuente: Psiquiatría, cuestionario 1.3, P1

52. Paciente de 55 años, con antecedente de 2 IAM, manejados con angioplastia, consulta muy angustiado porque luego del segundo infarto que ocurrió hace 2 semanas, el cardiólogo le ha dicho que debe realizarse un Bypass coronario, tras lo cual ha permanecido con insomnio, apetito disminuido y gran preocupación por el procedimiento. El diagnóstico más probable es:

a. Trastorno de ansiedad generalizada
b. Depresión
c. Trastorno adaptativo
d. Trastorno disociativo
e. Trastorno de pánico

Respuesta correcta: c. Trastorno adaptativo

Explicación: Es una pregunta difícil. Sin embargo, tiene un evento gatillante claro, por lo que puede ser un trastorno adaptativo, de tipo mixto, ya que tiene síntomas ansiosos (preocupación, insomnio) y anímicos (anorexia). También podría ser una depresión reactiva, por tener dos semanas y presentar insomnio y anorexia, pero le falta lo más importante: la tristeza o la anhedonia. Además, los síntomas no son tan intensos ni desproporcionados para los hechos que los gatillan.

Fuente: Psiquiatría, cuestionario 1.4, P4

53. Paciente de 16 años, consulta porque hace 10 días vio como un grupo de personas golpeaban a su padre por un ajuste de cuentas, episodio donde ella lo defendió y también resulto agredida. Tras lo cual ha estado con gran angustia, recuerdos y pesadillas recurrentes del hecho, insomnio y ha presentado crisis de pánico en 4 ocasiones. Refiere que tiene miedo de salir a la calle y se altera frente a cualquier ruido. El diagnóstico más probable es:

a. Trastorno de ansiedad generalizada

b. Trastorno por estrés agudo
c. Trastorno de pánico con agorafobia
d. Trastorno por estrés post traumático
e. Trastorno adaptativo

Respuesta correcta: b. Trastorno por estrés agudo

Explicación: Tiene un trastorno de estrés agudo clásico: presencia de un evento gatillante, percibido como amenazante para la vida propia o de los demás, reexperimentación (recuerdos y pesadillas), ansiedad, evitación y estado de hiperalerta. Como tiene menos de 4 semanas, es agudo. Si tuviese más, sería postraumático. El tratamiento del T. estrés agudo es con psicoterapia sola y, a lo más, un poco de benzodiacepinas para los síntomas ansiosos muy severos. El tratamiento del T. estrés postraumático, en cambio, puede hacerse con psicoterapia y/o IRS.

Fuente: Psiquiatría, cuestionario 1.4, P5

Trastornos somatomorfos, conversivos y disociativos (10)

54. Un paciente de 24 años reprueba su examen de grado y no llega ese día a su casa. Los familiares dan a aviso a carabineros y lo encuentran 2 semanas después en Collipulli, viviendo en una casa abandonada. Él no recuerda muy bien cómo llegó hasta ahí. El diagnóstico más probable es:

a. Trastorno conversivo
b. Psicosis reactiva
c. Trastorno adaptativo
d. Trastorno bipolar
e. Trastorno disociativo

Respuesta correcta: e. Trastorno disociativo

Explicación: Es una fuga disociativa clásica, que consiste en un tipo de amnesia disociativa (olvida parte importante de los recuerdos de su vida), al que se agrega que se va del lugar donde vivía a otro e, incluso, puede asociarse a la "creación" de una nueva autobiografía inventada. No suele afectar sus habilidades (ej. si es médico, seguirá sabiendo medicina, aunque no recuerde cómo se llama ni quienes son sus familiares). Al igual que los demás trastornos disociativos, se trata con psicoterapia, con buena probabilidad de recuperar los recuerdos y su vida previa.

Fuente: Psiquiatría, cuestionario 1.1, P13

55. Un paciente de 56 años consulta por cefalea de intensidad fluctuante, de predominio occipital. Además, presenta náuseas y dolor abdominal tipo cólico, con artralgias. En el último tiempo presenta también la sensación de tener un cuerpo extraño al tragar. Se ha realizado múltiples exámenes, los que descartan patología orgánica. El diagnóstico más probable es:

a. Trastorno adaptativo
b. Trastorno por hipocondría
c. Trastorno conversivo
d. Depresión
e. Trastorno por somatización

Respuesta correcta: e. Trastorno por somatización

Explicación: Tiene un T. de somatización clásico, consistente en múltiples síntomas de distintos tipos, sin una causa orgánica. El T. adaptativo tiene síntomas ansiosos o anímicos, luego de un evento crítico en la

vida. El T. por hipocondría tiene miedo a una enfermedad grave o progresiva, habitualmente sin muchos síntomas. El T. conversivo tiene síntomas neurológicos súbitos.

Fuente: Psiquiatría, cuestionario 1.2, P1

56. Una paciente de 45 años pierde de manera súbita el habla mientras discutía con su marido. Comprende bien el lenguaje, pero no puede evocar palabras ni sonidos. Cerca de 45 minutos después, comienza a recuperar progresivamente la voz. Su examen neurológico, así como su examen físico y neuroimágenes son totalmente normales. El diagnóstico más probable es:

a. Trastorno conversivo
b. Trastorno de personalidad histriónico
c. Trastorno por somatización
d. Trastorno disociativo
e. Trastorno de estrés agudo

Respuesta correcta: a. Trastorno conversivo

Explicación: Tiene un trastorno conversivo clásico: síntomas neurológicos de inicio súbito, sin una causa orgánica. En este caso tenía una afasia conversiva. En general, todos los T. de personalidad son una forma de ser (crónica y desde siempre). El T. somatización también es crónico y tiene síntomas de muchos tipos. El T. disociativo incluye el estupor disociativo, la fuga disociativa, la amnesia disociativa y los cuadros de desrealización y despersonalización.

Fuente: Psiquiatría, cuestionario 1.2, P8

57. Una paciente consulta por dolor abdominal y disuria. Además, refiere molestias en la espalda y mareos, los que la tienen preocupada. Cuenta con muchos exámenes que descartan patología orgánica. El diagnóstico más probable es:

a. Trastorno por hipocondría
b. Trastorno por somatización
c. Trastorno por conversión
d. Trastorno facticio
e. Trastorno disociativo

Respuesta correcta: b. Trastorno por somatización

Explicación: Es un trastorno por somatización clásico: síntomas de diversa índole sin causa orgánica. La hipocondría tiene pocos o ningún síntoma, pero sí tiene miedo a una enfermedad grave o progresiva, más desconfianza del médico. El trastorno conversivo (por conversión) se presenta como síntomas neurológicos súbitos, sin causa orgánica (ej. compromiso de conciencia, convulsiones o ceguera). El trastorno facticio finge o se autoprovoca intencionalmente síntomas, para ganar afectos y cuidados.

Fuente: Psiquiatría, cuestionario 1.3, P5

58. Una paciente sufre la muerte de su esposo, quedando en completo silencio por 24 horas, razón por la cual sus hijos deciden llevarla al hospital. No habla ni se mueve, permaneciendo sentada y sin establecer contacto visual con las demás personas. El diagnóstico más probable es:

a. Trastorno conversivo
b. Trastorno disociativo
c. Trastorno adaptativo
d. Trastorno de estrés agudo

e. Trastorno depresivo

Respuesta correcta: b. Trastorno disociativo

Explicación: Tiene un estupor disociativo clásico: inmovilidad y mutismo, en relación a un evento gatillante, en este caso.

Fuente: Psiquiatría, cuestionario 1.3, P14

59. Una paciente presenta una hemiparesia braquiocrural izquierda, luego de descubrir la infidelidad de su marido. Examen físico con ROT y tono muscular simétrico, fuerza levemente disminuida. El diagnóstico es:

a. T. facticio
b. T. conversivo
c. T. disociativo
d. T. de somatización
e. T. hipocondriaco

Respuesta correcta: b. T. conversivo

Explicación: Es un T. conversivo clásico: síntomas neurológicos súbitos, sin una causa orgánica identificable. Se trata con psicoeducación y psicoterapia, sin necesidad de fármacos, salvo comorbilidad que los requiera. Eso sí, con frecuencia los pacientes no aceptan el diagnóstico y no responden bien al tratamiento.

Fuente: Psiquiatría, cuestionario 1.4, P14

60. Paciente de 25 años cree que su cabeza es horrible, porque su frente es demasiado grande. Por eso usa peluca que le tapa la frente o se peina siempre hacia adelante. Al explicarle que su frente es normal, lo reconoce, pero aun así se siente muy mal con su aspecto. El diagnóstico más probable es:

a. Trastorno por somatización
b. Trastorno por hipocondría
c. Trastorno obsesivo compulsivo
d. Trastorno delirante crónico
e. Trastorno dismórfico corporal

Respuesta correcta: e. Trastorno dismórfico corporal

Explicación: Es un T. dismórfico corporal clásico: considera horrible una parte de su cuerpo y la oculta o quiere modificarla. El tratamiento del trastorno dismórfico corporal es difícil, pero incluye piscoeducación en el diagnóstico y en la inutilidad de las cirugías plásticas y procedimientos estéticos (suelen quedar disconformes). También sirven los IRS y/o la psicoterapia.

Fuente: Psiquiatría, cuestionario 1.4, P17

61. Una mujer de 20 años tiene una fuerte discusión con su novio, quien la insulta y termina con ella. En el episodio, pierde súbitamente la conciencia, manteniéndose así por cerca de 20 minutos. El examen físico es normal y los exámenes de laboratorio, así como las imágenes, descartan patología orgánica. El diagnóstico más probable es:

a. Trastorno de personalidad
b. Trastorno disociativo
c. Trastorno de somatización
d. Trastorno conversivo

e. Trastorno por simulación

Respuesta correcta: d. Trastorno conversivo

Explicación: Es un trastorno conversivo clásico (antiguamente se le llamaba histeria), que se caracteriza por síntomas neurológicos súbitos, sin causa orgánica. Suele estar desencadenado por estrés y tiene buen pronóstico, en la medida que el paciente acepte el diagnóstico. Se trata con psicoeducación. El trastorno por simulación se caracteriza por fingir los síntomas, con un fin ganancial económico (indemnización, pensión de invalidez, licencias médicas).

Fuente: Psiquiatría, cuestionario 1.5, P2

62. Una mujer siente que sus piernas son horribles, en especial sus rodillas, las que considera deformes, razón por lo que no usa traje de baño ni ropa corta, sino solo faldas largas o pantalones sueltos. Al ser enfrentada, reconoce que sus piernas pueden ser normales, pero que no puede evitar sentir que son horribles. El diagnóstico más probable es:

a. Trastorno obsesivo compulsivo
b. Trastorno delirante crónico
c. Trastorno dismórfico corporal
d. Trastorno por hipocondría
e. Trastorno fóbico social

Respuesta correcta: c. Trastorno dismórfico corporal

Explicación: Tiene un trastorno dismórfico corporal clásico: considera horrible una parte de su cuerpo y la oculta o busca cirugía plástica. Su reacción al confrontarla, de admitir que puede estar equivocada, da cuenta de que no está psicótica, sino que es un trastorno neurótico. El tratamiento del trastorno dismórfico corporal es difícil, pero incluye piscoeducación en el diagnóstico y en la inutilidad de las cirugías plásticas y procedimientos estéticos (suelen quedar disconformes). También sirven los IRS y/o la psicoterapia.

Fuente: Psiquiatría, cuestionario 1.5, P7

63. Una paciente sufre la muerte de su marido, evolucionando muy tranquila y asegurando que es imposible que su marido esté muerto, ya que solo se trata de un sueño y no es realidad. El diagnóstico más probable es:

a. Psicosis reactiva
b. Trastorno adaptativo
c. Trastorno disociativo
d. Trastorno conversivo
e. Reacción normal

Respuesta correcta: c. Trastorno disociativo

Explicación: Tiene un trastorno por desrealización, que es un tipo de trastorno disociativo.

Fuente: Psiquiatría, cuestionario 1.5, P18

Trastornos de personalidad (6)

64. Un paciente de 21 años es poco expresivo y no le interesan mucho las relaciones interpersonales. No tiene amigos íntimos y nunca ha tenido pareja ni relaciones sexuales. Él refiere que no le vive “feliz sin

esas cosas". Además, evita actividades en las que deba tener mucho contacto con los demás, ya que disfruta más de las actividades en solitario. El diagnóstico más probable es:

a. Trastorno distímico
b. Trastorno delirante crónico
c. Trastorno de personalidad
d. Esquizofrenia
e. Trastorno del espectro autista

Respuesta correcta: c. Trastorno de personalidad

Explicación: Es un T. personalidad esquizoide clásico: persona sin interés por las relaciones interpersonales, bastante frío y sin amigos ni relaciones sentimentales. No tiene psicosis (delirios ni alucinaciones), por lo que no parece T. delirante crónico, ni esquizofrenia, ni T. esquizoafectivo. La distimia tiene tristeza y disforia crónica (2 años y 1 año en adolescentes), sin cumplir criterios de depresión. El trastorno o condición del espectro autista, en los pacientes que logran un adecuado lenguaje, sí suele tener interés en las relaciones interpersonales, aunque tenga serias dificultades en lograrlas adecuadamente. Además, se caracterizan por tener intereses restringidas, rigidez cognitiva (dificultad para cambiar el pensamiento o comportamiento y adaptarse a los cambios), así como síntomas sensoriales. Ninguno de estos elementos se ve en el trastorno de personalidad esquizoide. Eso sí, hay algunos autores minoritarios, que tienden a englobar a la personalidad esquizoide dentro de el TEA, en sentido amplio.

Fuente: Psiquiatría, cuestionario 1.1, P4

65. ¿Cuál de los siguientes trastornos de personalidad se caracteriza por agresividad, impulsividad, inestabilidad emocional y escisión de la personalidad?

a. Antisocial
b. Histriónico
c. Límite
d. Paranoide
e. Esquizotípico

Respuesta correcta: c. Límite

Explicación: El T. límite o limítrofe de la personalidad se caracteriza por la inestabilidad, impulsividad, agresión y autoagresión, evitación desesperada del abandono y personalidad escindida y cambiante. El TP antisocial tiene falta de empatía y culpa, comisión de delitos, crueldad y agresividad. El TP histriónico busca ser el centro de atención, tiene preocupación por el aspecto y seducción y sí tiene labilidad emocional. El TP paranoide es celoso y desconfiado, además de molestarse fácilmente por cualquier cosa, ya que se siente atacado. El TP esquizotípico hoy se considera mayormente una esquizofrenia. Se caracteriza por ideas de referencia (creer que los acontecimientos externos se relacionan con uno mismo), las creencias en la magia y sobrenatural y también tiene conductas algo paranoides.

Fuente: Psiquiatría, cuestionario 1.1, P17

66. Un paciente de 20 años no tiene amigos íntimos y nunca ha tenido pareja. Tiene la sensación de que los demás lo encontrarán tonto o feo y por eso evita situaciones en las que tendrá contacto con personas nuevas o trabajos donde tendría que interactuar con muchas personas, ya que esto le causa ansiedad. El diagnóstico más probable es:

a. Trastorno de ansiedad

b. Trastorno de ansiedad generalizada
c. Trastorno fóbico social
d. Trastorno de personalidad evitativo
e. Trastorno distímico

Respuesta correcta: d. Trastorno de personalidad evitativo

Explicación: Es un trastorno de personalidad evitativo clásico: baja autoestima, evitación de las demás personas y relaciones interpersonales, por miedo al rechazo. Se diferencia de la fobia social, en que esta sí tiene amigos y relaciones sociales normales, solo que le genera mucha ansiedad hacer cosas en las que será evaluado por los demás (ej. exponer, cantar o hablar en público). Eso sí, hay quienes postulan que se trata de la misma patología, con distintos grados de severidad (siendo el más grave, el trastorno de personalidad evitativo).

Fuente: Psiquiatría, cuestionario 1.2, P7

67. Un paciente presenta importante labilidad emocional. Con facilidad se enoja y puede reaccionar agresivamente, lo que le ha traído problemas con familiares y amigos. Es muy impulsivo y cambia fácilmente de humor. Tiene una relación con una mujer, a quien dice amar, pero con la que ha terminado en varias oportunidades y luego regresan, con peleas frecuentes. Es hospitalizado ahora por un intento de suicidio. El diagnóstico más probable es:

a. Distimia
b. Trastorno de personalidad
c. Trastorno depresivo mayor
d. Trastorno delirante crónico
e. Trastorno bipolar

Respuesta correcta: b. Trastorno de personalidad

Explicación: Tiene un trastorno de personalidad limítrofe clásico: impulsividad, agresividad, labilidad emocional, autoagresión. Su pareja también se beneficiaría de atención de salud mental.

Fuente: Psiquiatría, cuestionario 1.3, P11

68. Paciente de 25 años es enviado desde trabajo a consultar ya que es muy ineficiente, perdiendo tiempo en realizar labores sencillas como archivar o enumerar carpetas, además presenta muy poca interacción con el resto. Al entrevistar al paciente parece apático, al preguntar por el motivo de consulta parece no interesarse en el tema y refiere que no ha tenido problemas en su trabajo y que consulta porque su familia lo presiona. Dentro de las sospechas diagnósticas debe incluirse:

a. Trastorno esquizoide de la personalidad y esquizofrenia
b. Trastorno bipolar
c. Distimia
d. Trastorno disociativo
e. Trastorno evitativo de la personalidad

Respuesta correcta: a. Trastorno esquizoide de la personalidad y esquizofrenia

Explicación: Parece una esquizofrenia simple, dada la predominancia de síntomas negativos, como la apatía, aplanamiento afectivo, ineficiencia y aislamiento. El trastorno esquizoide también es apático y no tiene interés por los demás, pero no necesariamente es ineficiente.

Fuente: Psiquiatría, cuestionario 1.4, P16

69. Un paciente de 29 años tiene muchos problemas con sus familiares, ya que es agresivo, en ocasiones les ha robado y agredió a su madre un día que se molestó con ella. Ha sido arrestado en 4 oportunidades por hurto en grandes tiendas y suele destruir el inmobiliario público cuando hay manifestaciones. El diagnóstico más probable es:

a. Trastorno de personalidad
b. Trastorno oposicionista desafiante
c. Trastorno bipolar
d. Trastorno delirante crónico
e. Trastorno facticio

Respuesta correcta: a. Trastorno de personalidad

Explicación: Tiene un trastorno de personalidad antisocial clásico: agresividad y transgresión de las normas legales y morales. Habitualmente no tienen remordimientos.

Fuente: Psiquiatría, cuestionario 1.5, P1

Psiquiatría infantil y del adolescente (5)

70. Un niño de 6 años tiene mal rendimiento escolar y además tiene mal comportamiento en el colegio, ya que no se queda quieto y si bien obedece al ser regañado, vuelve a molestar a los demás a los pocos minutos. El diagnóstico más probable es:

a. Síndrome de Asperger
b. Autismo
c. Déficit atencional
d. Trastorno de conducta
e. Trastorno oposicionista desafiante

Respuesta correcta: c. Déficit atencional

Explicación: Tiene un T. por déficit atencional de tipo hiperactivo (hiperactividad y mal rendimiento). El T. oposicionista desafiante no habría hecho caso, sino por el contrario, sería desobediente y agresivo.

Fuente: Psiquiatría, cuestionario 1.1, P5

71. Un niño de 13 años presenta muy mala conducta en el colegio y en la casa, metiéndose en peleas y obteniendo pésimas calificaciones. Con frecuencia insulta a su madre y patea a los perros de la casa. Además, su padre dice que le ha robado en varias ocasiones y que cree que está consumiendo marihuana y alcohol. El diagnóstico más probable es:

a. Trastorno oposicionista desafiante
b. Depresión
c. Adolescencia normal
d. Trastorno de conducta disocial
e. Trastorno por déficit atencional del niño

Respuesta correcta: d. Trastorno de conducta disocial

Explicación: El T. conducta se caracteriza por conductas claramente reñidas con las normas sociales y morales. En resumidas cuentas, es un adolescente "malo" (entendiendo que no existen niños malos), que está evolucionando a convertirse en un antisocial. El tratamiento es difícil y requiere intervenir fuertemente su red de apoyo, con lo que tiene opciones de revertir. Mientras antes y más intensamente

se intervenga, mejores resultados. El T. oposicionista desafiante tiene problemas con la autoridad y es desobediente y agresivo con la autoridad, pero no pelea con sus pares ni tampoco maltrata a los animales ni consume drogas.

Fuente: Psiquiatría, cuestionario 1.2, P17

72. Un niño de 4 años casi no habla, no es afectuoso y rechaza los besos o abrazos de las personas. La madre refiere que aplaude todo el tiempo y los profesores dicen que con frecuencia grita y no le gusta que lo toquen. El diagnóstico más probable es:

a. Déficit atencional
b. Trastorno de conducta
c. Trastorno del espectro autista
d. Depresión infantil
e. Parálisis cerebral

Respuesta correcta: c. Trastorno del espectro autista

Explicación: Es un TEA clásico, con la clínica del antiguo autismo: retraso de lenguaje, aislamiento social, manierismos (movimientos repetitivos, como aplausos, aleteo) y poca interacción con los demás. También suelen tener rigidez cognitiva, que dificulta los cambios, así como un patrón de intereses restringidos. Es frecuente que tengan alteraciones sensoriales, como que les molesten ciertas texturas o que los toquen.

Fuente: Psiquiatría, cuestionario 1.3, P15

73. Niña de 11 años, con mal rendimiento en colegio desde hace 2 meses, irritable y agresivo en el colegio, por lo que han llamado a su madre, la cual refiere que se ha comportado de la misma forma en su casa, desde hace un tiempo. Además, come poco y casi no sale de su pieza. El diagnóstico más probable es:

a. Normal
b. Trastorno de conducta
c. Trastorno oposicionista desafiante
d. Trastorno de la conducta alimentaria
e. Depresión

Respuesta correcta: e. Depresión

Explicación: Es una forma clásica de presentación de la depresión en niños: cambio conductual y disminución del rendimiento escolar. Por ser un cuadro que inició hace dos meses, es improbable que se trate de un T. conducta disocial (TCD) o un T. oposicionista (TOD) desafiante, ya que son trastornos crónicos. El TCD es un niño que ha sido difícil, pero que luego se va volviendo "malo" (miente, roba, maltrata, etc.). El TOD es un niño bueno, pero irritable, insolente, desobediente y agresivo con la autoridad.

Fuente: Psiquiatría, cuestionario 1.4, P15

74. Un niño es muy insolente y desobediente. Habitualmente es muy reticente a hacer lo que sus padres le piden y cuando se le obliga, grita, los insulta y hace rabietas, rompiendo las cosas que están a su alcance. El diagnóstico más probable es:

a. Trastorno por déficit atencional del niño
b. Trastorno oposicionista desafiante
c. Trastorno de conducta

d. Niño normal
e. Depresión

Respuesta correcta: b. Trastorno oposicionista desafiante

Explicación: Tiene un trastorno oposicionista desafiante (TOD) clásico: niño insolente, desobediente, que hace rabietas, es agresivo e insoportable, especialmente con la autoridad. El déficit atencional puede tener mal comportamiento, pero asociado a la hiperactividad y no a la desobediencia (son niños buenos, pero traviesos). El trastorno de conducta es un niño que no solo que se porta mal, sino que es malo: roba, miente, maltrata, etc. Las rabietas son normales (en particular entre los 2 y 3 años: "los terribles 2"), pero la agresividad y la intensidad de este caso, son más sugerentes de un TOD. En general, TOD, T. conducta, TEA, TDA, etc. se tratan con un enfoque multidisciplinario, que incluya intervención de la red de apoyo, con educación y psicoterapia sistémica, terapia ocupacional y mucho cariño. En casos más graves, se pueden indicar antipisóticos en dosis muy bajas para controlar la agresividad y los estimulantes como el metilfenidato para el control del déficit atencional y la inquietud psicomotora, pero idealmente se deben optimizar las medidas no farmacológicas.

Fuente: Psiquiatría, cuestionario 1.5, P16

Trastornos de la conducta alimentaria (3)

75. ¿Cuál de las siguientes alternativas es MENOS probable de presentarse en una paciente con anorexia nervosa?

a. Alteración de la autopercepción corporal
b. Amenorrea
c. Conductas impulsivas con pérdida del control sobre la comida
d. Personalidad de tipo obsesiva
e. Conductas de purga

Respuesta correcta: c. Conductas impulsivas con pérdida del control sobre la comida

Explicación: Los atracones (episodios de pérdida de control sobre la comida, con ingesta impulsiva) son propios de la bulimia y son muy raros en la anorexia. La anorexia se asocia a personalidad obsesiva compulsiva (muy controladora), mientras que la bulimia a la personalidad limítrofe (muy impulsiva). Las conductas de purga son más frecuentes en la bulimia, pero se pueden ver en la anorexia (anorexia restrictivo-purgativa).

Fuente: Psiquiatría, cuestionario 1.2, P15

76. A diferencia de la anorexia, la bulimia:

a. Presenta una excesiva preocupación por el peso
b. Se asocia a trastornos de la personalidad
c. Pierde el control sobre la comida
d. Se asocia a trastornos menstruales
e. No responde a la psicoterapia

Respuesta correcta: c. Pierde el control sobre la comida

Explicación: La bulimia se caracteriza por perder frecuentemente el control sobre la comida, presentando atracones. La anorexia, en cambio, es capaz de controlarlo y por lo mismo logra bajar tanto de peso. La anorexia tiene mayor preocupación por el peso, pero ambas la tienen. Ambas se asocian a T.

personalidad: bulimia a TP limítrofe y anorexia a TP obsesivo compulsivo. La anorexia es la que se asocia a amenorrea. Ambas responden a psicoterapia y, de hecho, la bulimia responde mejor.

Fuente: Psiquiatría, cuestionario 1.3, P16

77. La bulimia nervosa se diferencia de la anorexia nervosa principalmente en que la primera:

a. Pierde el control sobre la comida y presenta atracones
b. Presenta baja de peso
c. Presenta conducta de purga como uso de laxantes y autoinducción de vómitos
d. Está asociada a trastornos de la personalidad
e. Presenta amenorrea

Respuesta correcta: a. Pierde el control sobre la comida y presenta atracones

Explicación: La bulimia se caracteriza por los atracones (pérdida del control sobre la comida), mientras que estos son muy raros en la anorexia. La anorexia baja mucho más de peso que la bulimia (la que incluso puede subir de peso, por los atracones). La purga es propia de la bulimia, pero también es frecuente en la anorexia (come poco y luego vomita lo que comió o hace deporte, ya que no quiere engordar: se llama anorexia restrictivo-purgativa). Ambas se asocian a T. personalidad: TP TOC en la anorexia y TP límite en la bulimia. Solo la anorexia tiene amenorrea.

Fuente: Psiquiatría, cuestionario 1.5, P5

Demencias y delirium (9)

78. Un paciente de 63 años presenta problemas de memoria y una actitud más apática de la habitual. Los familiares refieren que en ocasiones sus ideas son algo “incoherentes” y se muestran muy preocupados porque presenta incontinencia urinaria y además se ha caído en varias oportunidades. El diagnóstico más probable es:

a. Delirium
b. Demencia frontotemporal
c. Demencia de Alzheimer
d. Demencia por cuerpos de Lewy
e. Hidrocefalia normotensiva

Respuesta correcta: e. Hidrocefalia normotensiva

Explicación: Tiene la triada clásica de la HNT: caídas, incontinencia urinaria y demencia.

Fuente: Psiquiatría, cuestionario 1.1, P11

79. Un paciente de 82 años presenta un cuadro de 48 horas de evolución, de agitación psicomotora, desorientación temporoespacial y tendencia a dormir. Al examen físico no presenta signos focales y no sabe bien donde está. El diagnóstico más probable es:

a. Síndrome confusional agudo
b. Delirium tremens
c. Demencia por cuerpos de Lewy
d. Demencia de Alzheimer
e. Delirio

Respuesta correcta: a. Síndrome confusional agudo

Explicación: Tiene un síndrome confusional agudo o delirium clásico: adulto mayor con desorientación, compromiso de conciencia y agitación. Suele producirse por alteraciones tóxico-metabólicas, como las infecciones. No se debe confundir con el delirio: síntoma psicótico, consistente en un conjunto de ideas que suponen una pérdida del juicio de realidad.

Fuente: Psiquiatría, cuestionario 1.1, P20

80. Un paciente de 72 años presenta un cuadro de malestar general y fiebre, de 48 horas de evolución, a lo que luego se le agrega desorientación y agitación psicomotora. Refiere que sus familiares lo quieren matar y ha presentado alucinaciones visuales. El diagnóstico más probable es:

a. Esquizofrenia
b. Enfermedad de Alzheimer
c. Demencia por cuerpos de Lewy
d. Delirium
e. Síndrome de abstinencia

Respuesta correcta: d. Delirium

Explicación: Tiene un síndrome confusional agudo o delirium clásico, probablemente secundario a una infección. Puede tener alucinaciones y delirios, como en este caso. La desorientación y agitación son características, pero la inatención y el compromiso de conciencia son lo más importante.

Fuente: Psiquiatría, cuestionario 1.2, P3

81. Un paciente de 70 años, con antecedente de olvidos frecuentes, presenta un cuadro de dos días de evolución de desorientación e insomnio. Sus familiares refieren que un vecino lo encontró vagando por las calles a las 3 de la mañana, sin saber dónde estaba. El diagnóstico más probable es:

a. Trastorno disociativo
b. Demencia por cuerpos de Lewy
c. Demencia por enfermedad de Alzheimer
d. Delirium
e. Esquizofrenia tardía

Respuesta correcta: d. Delirium

Explicación: Es un delirium o síndrome confusional agudo clásico: adulto mayor que se desorienta y compromete de conciencia. Probablemente cursa con una infección u otro trastorno tóxico-metabólico.

Fuente: Psiquiatría, cuestionario 1.3, P8

82. Un paciente de 66 años presenta un cuadro de algunos meses de evolución de pérdida de memoria y problemas cognitivos, relacionados con el uso de dinero y con algunas actividades cotidianas, como vestirse y cocinar. Además, ha presentado alucinaciones visuales y algunas caídas. Al examen físico presenta algún grado de rigidez de las extremidades superiores y disminución del braceo. El diagnóstico más probable es:

a. Demencia por cuerpos de Lewy
b. Delirium
c. Alzheimer
d. Demencia frontotemporal (de Pick)
e. Hidrocefalia normotensiva

Respuesta correcta: a. Demencia por cuerpos de Lewy

Explicación: Tiene una demencia por cuerpos de Lewy (DCL) clásica, dado que tiene la demencia con parkinsonismo y alucinaciones. Las caídas son clásicas también de la hidrocefalia normotensiva, pero en este caso se explican por el parkinsonismo. El delirium tiene alucinaciones, pero es un cuadro agudo. La demencia de Pick tiene desinhibición sexual y del comportamiento.

Fuente: Psiquiatría, cuestionario 1.3, P13

83. Paciente hospitalizado por neumonía presenta agitación y agresividad. Refiere que lo quieren matar y que hay monstruos en el lugar. ¿Cuál es el fármaco de elección para el tratamiento de este paciente?

a. Diazepam
b. Lorazepam
c. Fluoxetina
d. Clozapina
e. Haloperidol

Respuesta correcta: e. Haloperidol

Explicación: Tiene un delirium o síndrome confusional agudo, secundaria a la infección. Lo más importante es tratar la causa (la neumonía), pero como fármacos sirven los antipsicóticos en dosis bajas. De elección se usa haloperidol 0,5 mg oral (si lo acepta) o intramuscular e incluso endovenoso (se prefiere evitar el haloperidol por vía endovenosa, pero, en esa dosis es seguro). También se puede usar risperidona 1 mg vía oral o quetiapina 25 mg vía oral (esta última de elección en pacientes con Parkinson).

Fuente: Psiquiatría, cuestionario 1.4, P8

84. Un paciente de 65 años consulta por olvidos de acontecimientos recientes de un par de meses de evolución. Esto le preocupa en especial a su familia, ya que repite varias veces lo mismo y además ha tenido problemas con el uso del dinero en el último tiempo. Al examen físico está orientado y atento y coopera con la entrevista. Dice estar de buen ánimo y su examen neurológico es normal. La conducta más adecuada es:

a. Solicitar TAC de cerebro, TSH, VDRL y exámenes generales y controlar ambulatoriamente
b. Hospitalizar, solicitar TAC de cerebro, hemograma, pruebas hepáticas y de función renal, PCR y controlar con resultados
c. Enviar a domicilio, indicando donepezilo oral a permanencia
d. Solicitar glicemia, TSH y hemograma e iniciar fluoxetina
e. Explicar que la situación de este paciente es normal

Respuesta correcta: a. Solicitar TAC de cerebro, TSH, VDRL y exámenes generales y controlar ambulatoriamente

Explicación: Tiene una demencia: problemas de memoria, asociados a problemas cognitivos y de la vida diaria, que se han instalado de manera progresiva. Lo más correcto es estudiarla con múltiples exámenes, buscando una causa orgánica, dentro de las cuales las más importantes son la TSH (hipoT4), TAC de cerebro (descartar AVE, tumores y la hidrocefalia normotensiva), VDRL (sífilis), VIH y exámenes generales. No es necesario hacer el estudio hospitalizado, pero sí es importante que se haga relativamente rápido, ya que si se identifica alguna causa reversible, debe manejarse pronto. En cambio, el delirium se hospitaliza y se estudia con exámenes infecciosos y generales, de modo de identificar una causa aguda y tratarla de inmediato.

Fuente: Psiquiatría, cuestionario 1.4, P13

85. Un paciente de 80 años presenta problemas de memoria, caracterizados por olvidos de acontecimientos recientes y por repetición. Además, ha empezado con algunos problemas a la hora de manejar dinero. Su examen físico es normal. ¿Cuál de los siguientes medicamentos es más útil para el manejo de la enfermedad descrita?

a. Haloperidol
b. Donepecilo
c. Levodopa
d. Quetiapina
e. Sertralina

Respuesta correcta: b. Donepecilo

Explicación: Tiene una demencia y por solo tener afectación de la memoria reciente y algo de agnosia, probablemente tiene una enfermedad de Alzheimer. El tratamiento de la enfermedad de Alzheimer incluye educación de la red de apoyo, la prevención del estrés del cuidador y en las etapas iniciales sirven los inhibidores de la acetilcolinesterasa como el donepecilo, galantamina y rivastigmina. En cuadros moderados a severos, además, se recomienda agregar memantina. El Aducanumab (anticuerpos antiamiloide cerebral) aún no cuenta con evidencia que recomiende su uso.

Fuente: Psiquiatría, cuestionario 1.5, P6

86. Un paciente de 60 años presenta desde hace un año, problemas de memoria, asociados a deterioro cognitivo. Además, presenta alucinaciones visuales complejas y ha presentado varias caídas. El curso de la enfermedad ha sido fluctuante, pero con una tendencia a empeorar. Al examen físico presenta temblor de reposo de la mano izquierda. El diagnóstico más probable es:

a. Enfermedad de Alzheimer
b. Demencia por cuerpos de Lewy
c. Delirium
d. Hidrocefalia normotensiva
e. Demencia frontotemporal

Respuesta correcta: b. Demencia por cuerpos de Lewy

Explicación: Es una demencia por cuerpos de Lewy clásica: demencia, con alucinaciones y parkinsonismo. Además, se caracteriza por un curso fluctuante, pero a largo plazo, a diferencia del delirium, que fluctúa durante el día. Su tratamiento también suele ser con inhibidores de la acetilcolinesterasa (ej. donepecilo) o con memantina. Para el parkinsonismo, sirve la levodopa. - La enfermedad de Alzheimer no tiene alucinaciones ni parkinsonismo. - El delirium es un cuadro agudo. - La hidrocefalia normotensiva tiene demencia, caídas e incontinencia urinaria, más torpeza motora y una demencia de instalación subaguda. - La demencia frontotemporal se caracteriza por desinhibición del lenguaje y del comportamiento (ej. actitudes sexuales desadaptadas).

Fuente: Psiquiatría, cuestionario 1.5, P15

Psicofarmacología y efectos adversos (5)

87. Un paciente psiquiátrico, usando un medicamento cuyo nombre desconoce, evoluciona con malestar general, náuseas y vómitos, asociados a temblor de las extremidades y dificultades para caminar. Al examen físico presenta ataxia de la marcha y temblor de los brazos. ¿Qué fármaco es responsable de este cuadro?

a. Clorpromazina
b. Risperidona
c. Clozapina
d. Litio
e. Carbamazepina

Respuesta correcta: d. Litio

Explicación: Es una intoxicación clásica por litio (temblor, ataxia, compromiso gastrointestinal y compromiso de conciencia. Además, puede tener poliuria, por una especie de diabetes insípida nefrogénica). Se objetiva con litemia y se trata con suero fisiológico y, en los casos graves, con hemodiálisis. - La clorpromazina y risperidona (antipsicóticos) pueden producir parkinsonismo y otros síntomas extrapiramidales. - La intoxicación con carbamazepina produce convulsiones y compromiso de conciencia. En casos más graves puede evolucionar a un síndrome anticolinérgico (la risperidona también, pero es más raro).

Fuente: Psiquiatría, cuestionario 1.1, P9

88. ¿Cuál es el efecto adverso más frecuente de la risperidona?

a. Síntomas extrapiramidales
b. Náuseas
c. Disfunción sexual
d. Hipertensión arterial
e. Insomnio

Respuesta correcta: a. Síntomas extrapiramidales

Explicación: La risperidona es un antipsicótico, que por ser antidopaminérgicos, producen síntomas extrapiramidales. Los típicos, como el haloperidol, tienen estos efectos adversos con más frecuencia que los atípicos, como la riesperidona.

Fuente: Psiquiatría, cuestionario 1.2, P19

89. Un paciente de 30 años inicia tratamiento con quetiapina, evolucionando con gran inquietud. Refiere que se siente muy incómodo al quedarse quieto, por lo que se mueve constantemente y cambia continuamente de posición. El diagnóstico más probable es:

a. Manía aguda
b. Distonía aguda
c. Atetosis
d. Corea
e. Acatisia

Respuesta correcta: e. Acatisia

Explicación: Es una acatisia clásica: inquietud psicomotora por disestesias e incomodidad. Su tratamiento son los betabloqueantes (propanolol) y las benzodiacepinas. - La distonía presenta contracción tónica de

uno o varios músculos, con dolor (ej. tortícolis espasmódica). También se tratan con benzodiacepinas (ej. lorazepam endovenoso). - La atetosis son movimientos distales, reptantes. - El corea es similar a un baile con movimientos de manos y pies.

Fuente: Psiquiatría, cuestionario 1.3, P9

90. Paciente de 35 años, con antecedente de depresión severa con síntomas psicóticos, en tratamiento con fluoxetina y quetiapina, presenta dolor cervical asociado a rigidez y flexión lateral tónica, con imposibilidad de realizar movimientos con el cuello. Diagnóstico más probable:

a. Parkinsonismo
b. Distonía aguda
c. Atetosis
d. Corea
e. Balismo

Respuesta correcta: b. Distonía aguda

Explicación: Tiene una distonía clásica (contracción tónica y dolorosa de un grupo muscular), en específico, una tortícolis espasmódica. El parkinsonismo tiene rigidez, temblor de reposo y bradicinesia. Las atetosis son movimientos reptantes y distales. El corea es similar a un baile (como "La Macarena", pero ahora con Gente de Zona). El balismo es un movimiento súbito, de tipo proximal (ej. levantar súbitamente los brazos). Tratamiento distonía: - Si es por fármacos (ej. antipsicóticos) se debe retirar el fármaco y cambiar por uno que tenga menos efectos antidopaminérgicos. Además, se puede tratar con fármacos anticolinérgicos (benztropina o trihexifenidilo) o con benzodiacepinas (lorazepam o diazepam). - En las distonías primarias, se trata con levodopa. Si falla y son distonías focalizadas, se puede intentar con toxina botulínica; si son generalizadas, en cambio, se usan los anticolinérgicos.

Fuente: Psiquiatría, cuestionario 1.4, P9

91. Los efectos adversos más frecuentes de los antidepresivos inhibidores de la recaptura de serotonina son:

a. Síntomas extrapiramidaes
b. Astenia y síndrome " flu like"
c. Náuseas y disfunción sexual
d. Insomnio e irritabilidad
e. Somnolencia y alza de peso

Respuesta correcta: c. Náuseas y disfunción sexual

Explicación: Los IRS tienen pocos efectos adversos, pero los más frecuentes son boca seca, náuseas y alteraciones sexuales, como impotencia y disminución de la libido. En estos casos, se suelen reemplazar por la mirtazapina, un antidepresivo dual que no deteriora el área sexual. - Al suspenderlos bruscamente sí pueden producir un cuadro similar a una infección respiratoria ("flu like"). Los antipsicóticos producen extrapiramidalismo. Los tricíclicos, por su acción antiH1, producen somnolencia y alza de peso y, en las intoxicaciones agudas, pueden producir un rápido colapso circulatorio y síndrome anticolinérgico.

Fuente: Psiquiatría, cuestionario 1.4, P18

Consumo de sustancias y urgencias psiquiátricas (8)

92. Un paciente ingiere 20 comprimidos de alprazolam, con intención suicida. Al examen físico está en coma, con una frecuencia respiratoria de 4 respiraciones por minuto y cianosis. La conducta inicial más adecuada es:

a. Administrar naloxona y ventilar con ambú
b. Realizar intubación orotraqueal y ventilar con ambú
c. Administrar N-acetilcisteína y suero fisiológico por vía endovenosa
d. Administrar suero fisiológico por vía endovenosa
e. Administrar adrenalina endovenosa

Respuesta correcta: b. Realizar intubación orotraqueal y ventilar con ambú

Explicación: Lo más urgente en la intoxicación con benzodiazepinas es el ABC, en específico, asegurar la vía aérea y la ventilación. Como antídoto, además, se puede usar el flumazenil, pero su efecto es muy breve y errático, por lo que la ventilación y soporte sigue siendo lo más importante. La naloxona es el antídoto de la intoxicación con opiáceos (más la ventilación). La N-acetil-cisteína es el antídoto del paracetamol.

Fuente: Psiquiatría, cuestionario 1.1, P19

93. Identifique la asociación INCORRECTA entre la intoxicación y el tratamiento:

a. Metanol – etanol
b. Paracetamol – N-acetilcisteína
c. Cocaína – propanolol
d. Amitriptilina – carbón activado
e. Morfina – naloxona

Respuesta correcta: c. Cocaína – propanolol

Explicación: En la intoxicación por cocaína está absolutamente contraindicado el propanolol, ya que se puede generar una crisis hipertensiva (se bloquean los receptores beta, pero no los alfa, por lo que se produce una vasoconstricción masiva). Respecto a los tricíclicos, lo más importante es el soporte, pero sí sirve el carbón activado oral y el bicarbonato endovenoso. En los demás, se menciona el antídoto habitual.

Fuente: Psiquiatría, cuestionario 1.2, P4

94. Un paciente que consume una sustancia psicotrópica con cierta frecuencia, necesita cada vez dosis más altas para obtener el mismo efecto. Este concepto corresponde a:

a. Abstinencia
b. Dependencia
c. Abuso
d. Tolerancia
e. Up-regulation

Respuesta correcta: d. Tolerancia

Explicación: Es la definición de tolerancia: necesitar una dosis cada vez mayor para conseguir el mismo efecto. Vale la pena mencionar que suele producirse mediante mecanismos fisiopatológicos de up-regulation (sobreexpresión) o down-regulation (subexpresión) de receptores y neurotransmisores. Sin embargo, depende del tipo de sustancia el mecanismo que estará implicado. Abstinencia es el malestar

que se produce al no consumir. Dependencia tiene relación con la adicción (aunque para muchos es un concepto obsoleto). Abuso tiene relación con el consumo perjudicial (aunque también se considera un concepto obsoleto).

Fuente: Psiquiatría, cuestionario 1.2, P6

95. ¿Cuál de los siguientes fármacos es más útil para el abandono del hábito de fumar?

a. Disulfiram
b. Benzodiacepinas
c. Acamprosato
d. Bupropión
e. Sertralina

Respuesta correcta: d. Bupropión

Explicación: El bupropión es un antidepresivo dual que disminuye el craving o deseo de fumar. También sirve la vareniclina. El disulfiram se usa para dejar de consumir alcohol, como fármaco aversivo, aunque actualmente no se recomienda, dados sus efectos adversos. El acamprosato se usa como fármaco desmotivante, para mantener la abstinencia al alcohol, junto con psicoterapia cognitivo conductual.

Fuente: Psiquiatría, cuestionario 1.2, P18

96. Un paciente de 32 años, cursando una depresión, ingiere 45 comprimidos de amitriptilina hace 2 horas, con intención de suicidarse. Al examen físico está taquicárdico, orientado, sin otras alteraciones, con un electrocardiograma que muestra una taquicardia sinusal. La conducta más adecuada es:

a. Hospitalizar, indicar carbón activado por SNG, atropina endovenosa y realizar monitorización electrocardiográfica
b. Hospitalizar, realizar lavado gástrico, indicar carbón activado por SNG, bicarbonato endovenoso y realizar monitorización electrocardiográfica
c. Hospitalizar, indicar N-acetil-cisteína por vía e.v. y realizar monitorización electrocardiográfica
d. Mantener en observación por 24 horas, sin medidas adicionales, a menos que presente alguna complicación
e. Conectar al ventilador mecánico y controlar con niveles plasmáticos de amitriptilina

Respuesta correcta: b. Hospitalizar, realizar lavado gástrico, indicar carbón activado por SNG, bicarbonato endovenoso y realizar monitorización electrocardiográfica

Explicación: Lo más importante en la intoxicación con antidepresivos tricíclicos es el soporte circulatorio y el monitoreo electrocardiográfico (evoluciona a taquicardias ventriculares y, antes, presenta alteraciones del QRS: se ensancha, cambia morfología). Para acelerar la eliminación, sirve alcalinizar la orina, con bicarbonato endovenoso, que también sirve para reducir la toxicidad cardíaca, cuando hay alteraciones electrocardiográficas. Junto con esto, se puede dar el manejo general de las intoxicaciones: carbón activado por ejemplo. El lavado gástrico, por lo que general solo se indica si lleva menos de 1 hora, pero en los tricíclicos se puede hacer incluso luego de 2 a 4 horas, ya que retardan el vaciamiento gástrico.

Fuente: Psiquiatría, cuestionario 1.3, P10

97. Paciente de 24 años, de estudiante de medicina, es traído por presentar diaforesis, taquicardia y fiebre de horas de evolución. Al examen físico se aprecia intranquilo, con pupilas midriáticas, temblor fino de extremidades y taquipnea. ¿Cuál de las siguientes alternativas es la causa más probable de su cuadro?:

a. Clonazepam
b. Anfetaminas

c. Guaraná
d. Canabis
e. Modafinilo

Respuesta correcta: b. Anfetaminas

Explicación: Tiene un síndrome adrenérgico: HTA, taquicardia, sudoración y midriasis. De las opciones, las anfetaminas es lo más probable (ej. D-anfetamina o el metilfenidato, que es un derivado). En la práctica, los síndromes adrenérgicos, anticolinérgicos y serotoninérgicos pueden ser extremadamente similares y difíciles de distinguir.

Fuente: Psiquiatría, cuestionario 1.4, P10

98. Un paciente presenta taquicardia, fiebre, hipertensión arterial y midriasis. ¿Qué sustancia puede ser responsable de este cuadro?

a. Tetrahidro-canabinol
b. Cocaína
c. Ácido lisérgico
d. Heroína
e. Diazepam

Respuesta correcta: b. Cocaína

Explicación: Tiene un síndrome adrenérgico: taquicardia, HTA, midriasis e hipertermia. La cocaína y las anfetaminas son las causas más clásicas. La intoxicación por THC (marihuana) tiene sedación. El ácido lisérgico o LSD tiene alucinaciones. La heroína produce compromiso de conciencia, miosis puntiforme y depresión respiratoria (síndrome opiáceo). El diazepam produce compromiso de conciencia y depresión respiratoria (síndrome narcótico): puede tener ligera miosis o pupilas normales.

Fuente: Psiquiatría, cuestionario 1.5, P14

99. Un paciente de 60 años, alcohólico, presenta un cuadro de marcada agitación psicomotora y alucinaciones de serpientes que lo atacan. Además, se aprecia temblor de las extremidades superiores. El fármaco que se debe administrar es:

a. Haloperidol
b. Diazepam
c. Quetiapina
d. Flumazenil
e. Disulfiram

Respuesta correcta: b. Diazepam

Explicación: Tiene un delirium tremens clásico (una forma del síndrome de privación alcohólica grave). Se caracteriza por temblor, agitación y alucinaciones de pequeños animales (microzoopsias). Se trata con benzodiacepinas: diazepam de elección y lorazepam, si es que hay daño hepático crónico. 1.- Resumen

Fuente: Psiquiatría, cuestionario 1.5, P20

Dermatología (120)

Dermatitis y eccemas (15)

1. Un paciente presenta una placa eritematosa de larga evolución en el tobillo derecho, que es muy pruriginosa. Al examen físico se aprecian signos de rasquido, con engrosamiento de la piel y liquenificación. El diagnóstico más probable es:

a. Liquen plano
b. Liquen simple crónico (neurodermatitis)
c. Eccema numular
d. Psoriasis
e. Dermatitis de contacto

Respuesta correcta: b. Liquen simple crónico (neurodermatitis)

Explicación: Es un liquen simple crónico clásico: placa liquenificada y pruriginosa, secundaria a rascarse. Los tobillos son sitios clásicos, ya que se rascan con el otro pie. El liquen plano también puede estar en los tobillos (suele estarlo), pero son pápulas pruriginosas. El eccema numular se caracteriza por lesiones redondeadas (como monedas) y se asoacia a atopía.

Fuente: Dermatología, cuestionario 4.1, P1

2. Un niño presenta dermatitis atópica. La medida más importante para el tratamiento crónico de este paciente es:

a. Antihistamínicos orales
b. Protector solar
c. Crema humectante
d. Corticoides tópicos
e. Inhibidores de los leucotrienos orales

Respuesta correcta: c. Crema humectante

Explicación: La humectación y el uso de emolientes es la medida más importante para la atopía. Si está muy activa, se pueden indicar corticoides tópicos. Los inhibidores de la calcineurina (ej. tacrolimus) se pueden usar y, de hecho se prefieren antes que los corticoides en pliegues y zonas en que se puede atrofiar la piel. De última línea, están los biológicos (dupilumab, por ejemplo, que es un anticuerpo contra el IL-4). También debe recibir bloqueador solar, como todos, pero la crema humectante es lo principal.

Fuente: Dermatología, cuestionario 4.1, P7

3. Un paciente presenta eritema, pápulas y vesículas ubicadas en la cara, cuello y manos, asociadas a ardor, que aparecieron hace un día, luego de haber participado en una excursión al cerro. Algunos de sus acompañantes manifestaron síntomas similares. El diagnóstico más probable es:

a. Dermatitis de contacto
b. Prúrigo
c. Reacción fototóxica
d. Reacción fotoalérgica
e. Quemadura

Respuesta correcta: d. Reacción fotoalérgica

Explicación: Es una clásica reacción fotoalérgica al litre, también llamada fitofotodermatosis. El litre es un árbol que está ubicado en los cerros de la zona central de Chile. Es bastante común y, lamentablemente es muy similar a otros árboles del bosque esclerófilo, típico de la zona central de Chile. Por esa razón, la recomendación es siempre usar bloqueador solar al hacer trekking y evitar el contacto de la piel con los árboles. De todos modos, les dejamos algunas imágenes para que lo conozcan: No hay ninguna descripción de la foto disponible. Fuente imágenes: Fundación Reforestemos y Nativos de Cantillana.

Fuente: Dermatología, cuestionario 4.1, P12

4. Un paciente de 22 años presenta desde hace 5 días, aparición de una lesión eritematosa muy pruriginosa en la cara latero-dorsal de los dedos pulgar, índice y medio derecho, con múltiples vesículas tensas, muy pruriginosas. El diagnóstico más probable es:

a. Dermatitis de contacto alérgica
b. Liquen simple
c. Liquen plano
d. Eccema dishidrótico
e. Dermatitis atópica

Respuesta correcta: d. Eccema dishidrótico

Explicación: Es un eccema dishidrótico o pónfolix o dishidrosis clásica: vesículas tendas y pruriginosas, sobre base eritematosa, en manos y pies (se asocian a alergia y a infección por hongos). El tratamiento suele ser con corticoides tópicos, durante los brotes y, si es muy intenso, se puede dar prednisona oral. Además, es muy frecuente que se identifiquen desencadenantes claros, como contactantes (ej. detergente), los cuales hay que evitar. - La dermatitis de contacto alérgica puede verse igual, pero suele ser sin vesículas y ubicarse en las zonas de contacto con el alérgeno. - El liquen simple es una placa eritematosa, pruriginosa y liquenificada (demarcación del dibujo cutáneo), sin vesículas.

Fuente: Dermatología, cuestionario 4.1, P17

5. Un paciente de 28 años presenta pápulas pruriginosas que suelen aparecer en las fosas poplíteas. Tiene tendencia a la sequedad de la piel y se aprecia queratosis pilar. Además se aprecian sus labios partidos. El diagnóstico más probable es:

a. Dermatitis herpetiforme
b. Psoriasis
c. Dermatitis atópica
d. Liquen plano
e. Liquen simple crónico

Respuesta correcta: c. Dermatitis atópica

Explicación: Es una dermatitis atópica clásica, tanto por los signos de atopía (sequedad de la piel, queratosis pilar y labios partidos), como por la ubicación clásica de las lesiones: fosas poplíteas y pliegues cubitales. En niños es muy frecuente el compromiso de mejillas y del cuello. Fuente: https://www.mayoclinic.org/

Fuente: Dermatología, cuestionario 4.2, P10

6. Una paciente presenta una placa hiperpigmentada y liquenificada, de 6 cm de diámetro, usualmente pruriginosa, no dolorosa, ubicada en la zona infraumbilical, de varias semanas de evolución, que en ocasiones disminuye de tamaño, pero luego vuelve a crecer. Además se aprecian sus dedos agrietados. El diagnóstico más probable es:

a. Dermatomiositis
b. Esclerodermia
c. Liquen simple crónico
d. Liquen plano
e. Dermatitis de contacto alérgica

Respuesta correcta: e. Dermatitis de contacto alérgica

Explicación: Solo por la ubicación, es posible sospechar una dermatitis de contacto alérgica. En el ombligo, por alergia al níquel (del botón del pantalón o de la hebilla del cinturón). En los dedos, por el lavalozas u otro producto de limpieza. La dermatomiositis tiene rash en párpados (heliotropo), en tronco (en manto) y en nudillos (Gottron). La esclerodermia tiene esclerosis de dedos, fenómeno de Raynaud, disfagia y telangiectasias faciales, con fascies de pájaro. El liquen simple crónico puede verse como una placa pruriginosa u liquenificada y puede estar hiperpigmentada, pero la ubicación suele ser una zona de rasquido (tobillos, cuello, espalda y brazos). El liquen plano son pápulas en tobillos y muñecas.

Fuente: Dermatología, cuestionario 4.2, P12

7. Un niño presenta pápulas pruriginosas en las mejillas y los antebrazos. Al examen se aprecia pitiriasis alba en la cara. El diagnóstico más probable es:

a. Dermatitis seborreica
b. Pitiriasis versicolor
c. Demodecidiosis
d. Dermatitis de contacto
e. Dermatitis atópica

Respuesta correcta: e. Dermatitis atópica

Explicación: Tanto por los signos de atopía (pitiriasis alba), como por la ubicación clásica (mejillas en niños, más zonas flexoras: cara anterior de antebrazos y pliegues cubitales), se trata de una dermatitis atópica. La demodecidiosis es causada por el ácaro démodex y puede exacerbar o producir rosácea.

Fuente: Dermatología, cuestionario 4.3, P1

8. Una paciente presenta una placa moderadamente pruriginosa en la zona infraumbilical, liquenificada y con lesiones similares en ambas orejas. El diagnóstico más probable es:

a. Liquen plano
b. Liquen simple crónico
c. Dermatitis de contacto alérgica crónica
d. Dermatitis de contacto irritativa crónica
e. Dermatitis atópica

Respuesta correcta: c. Dermatitis de contacto alérgica crónica

Explicación: Solo por la ubicación, parece una dermatitis de contacto alérgica, con alergia al níquel: afecta las orejas por alergia a los aros y afecta el ombligo por alergia al botón del pantalón o a la hebilla del cinturón. El liquen plano tiene pápulas en tobillos y muñecas. El liquen simple crónico tiene una placa

liquenificada en una zona de rasquido. La dermatitis irritativa exige exposición a un irritante. La dermatitis atópica suele estar ubicada en las fosas poplíteas y cubitales.

Fuente: Dermatología, cuestionario 4.3, P14

9. Consulta un paciente de 30 años por lesiones recidivantes en el cuero cabelludo, consistentes en eritema asociado a abundante descamación. Al examinarlo se aprecia también compromiso del puente nasal. El diagnóstico más probable es:

a. Dermatitis de contacto
b. Rosácea
c. Lupus sistémico
d. Dermatitis seborreica
e. Lupus discoide

Respuesta correcta: d. Dermatitis seborreica

Explicación: Es una dermatitis seborreica clásica: eritema y descamación amarillenta, que afecta el cuero cabelludo (sin sobrepasar la línea de implantación del pelo, a diferencia de la psoriasis), la zona nasal y ciliar (cejas). En adultos se suele tratar con champú de ketoconazol y/o corticoides tópicos de baja potencia en las lesiones más inflamatorias. En lactantes, en cambio, se suele observar, ya que es autolimitada, aunque se puede usar vaselina líquida o aceite mineral para limpiar las costras. - La dermatitis de contacto afecta las zonas de contacto y puede tener distintos dignos de inflamación, como eritema, rezumación y vesículas (aguda), solo eritema y pápulas (subaguda) o liquenificación y cambios en la pigmentación (crónica). - El lupus discoide sí puede afectar el cuero cabelludo, pero como placas eritematosas y descamativas, con caída de cabello, que involucionan dejando una cicatriz e incluso alopecia cicatricial.

Fuente: Dermatología, cuestionario 4.4, P4

10. Un niño realiza una excursión a la precordillera, con algunos amigos. Es traído por aparición de lesiones eritematosas, con algunas vesículas y pequeñas bulas, en la cara y los antebrazos, de disposición lineal, que presentan ardor. El diagnóstico más probable es:

a. Reacción fototóxica
b. Fitofotodermatosis
c. Dermatitis de contacto alérgica
d. Prúrigo
e. Pénfigo

Respuesta correcta: b. Fitofotodermatosis

Explicación: Es una reacción al litre (árbol de la zona central de Chile) clásica. La disposición lineal es por la forma en que se produce el roce con las hojas del árbol. Requiere además de exposición solar, por lo que se llama reacción fotoalérgica o fitofotodermatosis (fito = planta; foto = luz). No se debe confundir a la reacción fototóxica, que es la que ocurre al exponerse al sol, habiendo consumido algunos medicamentos, como las tetraciclinas y la isotretinoína.

Fuente: Dermatología, cuestionario 4.4, P12

11. Un niño de 5 meses de edad es traído por su madre, por lesiones en su cara. Al examen físico se aprecian pápulas eritematosas y descamación en ambas mejillas y también algunas en los codos. El diagnóstico más probable es:

a. Dermatitis seborreica

b. Escabiosis
c. Dermatitis atópica
d. Liquen plano
e. Millium sebáceo

Respuesta correcta: c. Dermatitis atópica

Explicación: Es una dermatitis atópica clásica. Se debe recordar que en los lactantes, los sitios clásicos son las mejillas, las zonas extensoras (codos y rodillas) y el cuero cabelludo, es decir, las zonas de roce. En los niños mayores, en cambio, las zona más frecuentes son las zonas flexoras, es decir, las zonas de sudor.

Fuente: Dermatología, cuestionario 4.5, P4

12. Estudiante de medicina de 24 años, sin antecedentes, consulta por presentar lesiones eritematosas en ambas manos, muy pruriginosas, que iniciaron hace 10 días y han ido en aumento. Al examen físico se aprecian vesículas y pápulas en las caras laterales de los dedos pulgar e índice de ambas manos, sobre una base eritematosa. El diagnóstico más probable es: El diagnóstico más probable es:

a. Dermatitis atópica
b. Herpes zóster
c. Dermatitis de contacto alérgica
d. Dishidrosis
e. Impétigo buloso

Respuesta correcta: d. Dishidrosis

Explicación: Es una dishidrosis, o eccema dishidrótico o pónfolix clásico. Se caracteriza por prurito intenso, con aparición de vesículas muy tensas en particular en los dedos y también en manos y pies, afectando tanto el dorso, como las palmas y plantas. Suele desencadenarse en periodos de estrés o por contacto con alérgenos, los que deben identificarse y evitarse. Se trata con corticoides tópicos más antihistamínicos orales. Los casos muy severos se manejan con prednisona oral.

Fuente: Dermatología, cuestionario 4.5, P5

13. Lactante de 5 meses, con antecedente de prematurez, es traída por aparición de lesiones en zona del pañal, asociado a irritabilidad. Al examen físico se observa lo siguiente: ¿Qué tratamiento está indicado en este caso?

a. Indicar cambios frecuentes de pañal y aplicación de crema humectante
b. Indicar cambios frecuentes de pañal y antimicóticos tópicos
c. Indicar cambios frecuentes de pañal y antimicóticos orales
d. Indicar cambios frecuentes de pañal y antibióticos tópicos
e. Indicar cambios frecuentes de pañal y antibióticos orales

Respuesta correcta: b. Indicar cambios frecuentes de pañal y antimicóticos tópicos

Explicación: Tiene una micosis o candidiasis del pañal (ya que se ven las lesiones satélites). La dermatitis del pañal, en general se trata con óxido de zinc como barrera, más los cambios frecuentes del pañal. Cuando existe alta sospecha de cándida, por presencia de lesiones satélites y/o compromiso de los pliegues, además, se agregan los antimicóticos tópicos, como nistatina o clotrimazol.

Fuente: Dermatología, cuestionario 4.5, P6

14. Paciente de 50 años, con antecedente de diabetes en regular tratamiento, consulta por presencia de caspa abundante y sequedad frontal. Al examen físico se observa leve eritema de cuero cabelludo

asociado a caspa abundante, además se encuentran lesiones similares en frente y cejas. El fármaco más adecuado para el manejo de este caso es:

a. Permetrina al 1%
b. Ketoconazol tópico
c. Griseofulvina oral
d. Metronidazol tópico
e. Prednisona oral

Respuesta correcta: b. Ketoconazol tópico

Explicación: Tiene una dermatitis seborreica clásica: eritema y descamación en cuero cabelludo, cejas, nariz y frente. Es causada por un hongo, el Pitirosporum ovale, por lo que el tratamiento de primera línea son los antimicóticos tópicos (champú de ketoconazol en el cuero cabelludo; crema de clotrimazol o ketoconazol en la cara). Además, se puede agregar un poco de corticoides tópicos en especial si las lesiones faciales son muy inflamatorias. En los lactantes, en cambio, se debe observar o, a lo más, indicarles vaselina líquida para remover las costras. Solo en casos extremos que persistente, se usan fármacos. Si los padres insisten en que quieren un fármaco, pues se los educa amablemente; si siguen insistiendo se les dice "aers... ¿quién es el dostor?".

Fuente: Dermatología, cuestionario 4.5, P7

15. Un paciente consulta por eritema y ardor en ambas axilas, que inició hace 24 horas. Al examen físico se aprecia una placa eritematosa, en cada axila. El diagnóstico más probable es:

a. Prúrigo
b. Dermatitis de contacto alérgica
c. Hidrosadenitis
d. Pénfigo
e. Impétigo buloso

Respuesta correcta: b. Dermatitis de contacto alérgica

Explicación: Es una dermatitis de contacto clásica, al desodorante. La hidrosadenitis es una patología en que se obstruyen las glándulas sudoríparas apocrinas, generando dolor y abscesos.

Fuente: Dermatología, cuestionario 4.6, P10

Psoriasis, liquen y dermatosis papuloescamosas (13)

16. Un paciente de 18 años presenta placas levemente eritematosas, con descamación suave en el tronco, de 5 días de evolución, sin otros síntomas. El diagnóstico más probable es:

a. Psoriasis
b. Dermatitis seborreica
c. Psoriasis guttata
d. Pitiriasis versicolor
e. Pitiriasis rosada

Respuesta correcta: e. Pitiriasis rosada

Explicación: Es una pitiriasis rosada clásica: lesiones eritematodescamativas limitadas al tronco. Pueden ser pruriginosas o asintomáticas. Generalmente no requiere ningún tipo de tratamiento, ya que suele desaparecer espontáneamente en un lapso de 2 a 3 meses. Así que, se debe educar al paciente sobre ello.

En los casos muy severos, se pueden indicar corticoides tópicos y algunos indican aciclovir, ya que se cree que es causada por virus herpes 7 o 6, aunque la evidencia sobre su etiología y el rol de los antivirales es escasa (quedarse con la idea de que no requiere tratamiento). - La psoriasis se localiza en zonas extensoras y cuero cabelludo, sobrepasando la línea del pelo. - La dermatitis seborreica se localiza en cejas, nariz y cuero caberrudo, respetando la línea del pelo. - La psoriasis guttata se localiza en todo el cuerpo, respetando las palpas y plantas y tiene lesiones similares a gotas (en su tamaño). - La pitiriasis versicolor sí se localiza en el tronco, pero son lesiones hipopigmentadas.

Fuente: Dermatología, cuestionario 4.1, P5

17. Un paciente de 30 años presenta lesiones muy pruriginosas en las muñecas y en los tobillos, consistentes en pequeñas pápulas eritemato-violáceas, recidivantes. El diagnóstico más probable es:

a. Eccema dishidrótico
b. Eccema numular
c. Dermatitis atópica
d. Liquen escleroso
e. Liquen plano

Respuesta correcta: e. Liquen plano

Explicación: Es un liquen plano clásico, caracterizado por pápulas pruriginosas, en muñecas y tobillos, las que se describen como pápulas pequeñas, pruriginosas, poligonales, púrpuras y prillantes (brillantes). Algunas imágenes de referencia: Liquen Plano, Síntomas, Causas y Tratamiento - Dr. Gabriel Serrano Fuente: https://drgabrielserrano.com/ Fuente: https://www.institutimipo.com Fuente: http://cdeermard.com

Fuente: Dermatología, cuestionario 4.2, P2

18. Una mujer de 23 años consulta por lesiones cutáneas de algunos días de evolución, que no presentan dolor ni prurito. Al examen físico se observan múltiples placas de 5-20 mm de diámetro, ubicadas en el tronco, de color levemente eritematoso, con una fina descamación. El diagnóstico más probable es:





a. Sífilis secundaria
b. Psoriasis
c. Pitiriasis versicolor
d. Lupus discoide
e. Pitiriasis rosada de Gibert

Respuesta correcta: e. Pitiriasis rosada de Gibert

Explicación: Es una pitiriasis rosada clásica: lesiones eritematodescamativas en tronco y zona proximal de las extremidades, de color rosadas. Suele ser autolimitada, resolviéndose en 2 a 3 meses y no requiere tratamiento. Algunos ejemplos de imagen: Fuente: https://www.ryzdermatech.com/ Fuente: https://semanariofides.com/2014/01/24/pitiriasis-rosada/ - La sífilis secundaria afecta todo el cuerpo, incluyendo palmas y plantas. - La psoriasis afecta zonas extensoras y cuero cabelludo. La pitiriasis versicolor tiene máculas hipopigmentadas en pecho y espalda. El lupus discoide tiene placas eritamodescamativas en zonas fotoexpuestas y deja cicatriz (y alopecia cicatricial definitiva).

Fuente: Dermatología, cuestionario 4.2, P5

19. Un paciente de 27 años presenta placas eritematosas, descamativas, ubicadas en los codos y rodillas, con lesiones tipo ungueales puntiformes, depremidas. El diagnóstico más probable es:

a. Liquen plano
b. Tiña
c. Psoriasis
d. Liquen simple
e. Eccema dishidrótico

Respuesta correcta: c. Psoriasis

Explicación: Es una psoriasis clásica: placas eritematodescamativas en zonas extensoras. Además, tiene las lesiones ungueales clásicas, en picotazo de pájaro. El eccema dishidrótico se caracteriza por vesículas muy pruriginosas y tensas, ubicadas en las manos y pies, que aparecen con el estrés y con la exposición a contactantes.

Fuente: Dermatología, cuestionario 4.3, P9

20. Un paciente presenta hace unos días aparición de placas eritematosas descamativas de hasta 1 cm de diámetro, que comprometen la cara, tronco y extremidades, respetando palmas y plantas. El diagnóstico más probable es:

a. Pitiriasis rosada
b. Psoriasis vulgar
c. Psoriasis guttata
d. Sífilis secundaria.
e. Pitiriasis versicolor

Respuesta correcta: c. Psoriasis guttata

Explicación: Salvo la pitiriasis versicolor, que produce lesiones hipopigmentadas en pecho y espalda, todas las opciones presentan lesiones eritematodescamativas, pero la distribución hace la diferencia. La pitiriasis rosada se limita al tronco. La psoriasis está en zonas extensoras (espalda, rodillas, codos). La psoriasis guttata es generalizada, pero respetando palmas y plantas (como este caso). La sífilis secundaria afecta las palmas y plantas. A modo de cultura general, el tratamiento de la psoriasis guttata suele ser la fototerapia con luz UVB.

Fuente: Dermatología, cuestionario 4.3, P15

21. ¿Cuál de las siguientes patologías afecta más frecuentemente la mucosa oral?

a. Rosácea
b. Liquen simple crónico
c. Psoriasis
d. Liquen plano
e. Pitiriasis rosada de Gibert

Respuesta correcta: d. Liquen plano

Explicación: El 50% de los líquenes planos tienes afectación de la mucosa oral, la que se ve como una placa reticular de color blanquecino. La rosácea afecta los ojos.

Fuente: Dermatología, cuestionario 4.3, P18

22. Un paciente de 27 años consulta por lesiones pruriginosas en sus tobillos. Al examen físico presenta múltiples lesiones papulares, muy pruriginosas, de color eritemato-violáceas. Refiere que en ocasiones aumentan en cantidad y en otras tienden a disminuir. El diagnóstico más probable es:

a. Dermatitis atópica
b. Dermatitis de contacto alérgica
c. Urticaria
d. Liquen simple crónico
e. Liquen plano

Respuesta correcta: e. Liquen plano

Explicación: Es un liquen plano clásico: lesiones papulares pruriginosas, ubicadas en muñecas o tobillos. Además, suelen ser de color púrpura y tienden a la cronicidad. La dermatitis atópica suele afectar fosas cubitales y poplíteas y se asocia a piel seca y otros signos de atopía. La urticaria tiene pseudopápulas o ronchas y en ocasiones, habones (roncha muy grande). El liquen simple crónico sí puede afectar los tobillos, pero no son pápulas sino una placa pruriginosa y liquenificada (con la piel engrosada y con demarcación del dibujo cutáneo).

Fuente: Dermatología, cuestionario 4.4, P1

23. Un paciente de 18 años presenta aparición de múltiples placas eritematosas, con fina descamación, en el tronco, que no duelen ni pican. Refiere que una semana antes solo tenía una lesión en la espalda, algo más grande que las demás. El diagnóstico más probable es:

a. Pitiriasis rosada
b. Urticaria
c. Psoriasis gutatta
d. Psoriasis vulgar
e. Sífilis secundaria

Respuesta correcta: a. Pitiriasis rosada

Explicación: Es una pitiriasis rosada clásica: mancha heráldica que algunos días después es seguida de un exantema eritematodescamativo que afecta el tronco. Es autolimitada, durando 2 a 3 meses. Se debe educar al paciente sobre ello. - La urticaria no tiene placas, sino ronchas. Se trata con antihistamínicos. - La psoriasis guttata sí tiene lesiones eritematodescamativas, pero afectan además la cabeza y extremidades (respetando palmas y plantas). Se trata con fototerapia UVB. - La sífilis secundaria afecta palmas y plantas. Se trata con penicilina. - La psoriasis vulgar tiene placas en espalda, cuero cabelludo y zonas extensoras (rodillas, codos). Se trata con corticoides tópicos y crema humectante (ej. de urea). Los casos más graves se tratan con fototerapia.

Fuente: Dermatología, cuestionario 4.4, P3

24. Una mujer consulta por prurito en la zona genital, de varias semanas de evolución. Al examen físico se aprecia eritema y atrofia cutánea alrededor de la vulva, sin compromiso de la mucosa. El diagnóstico más probable es:

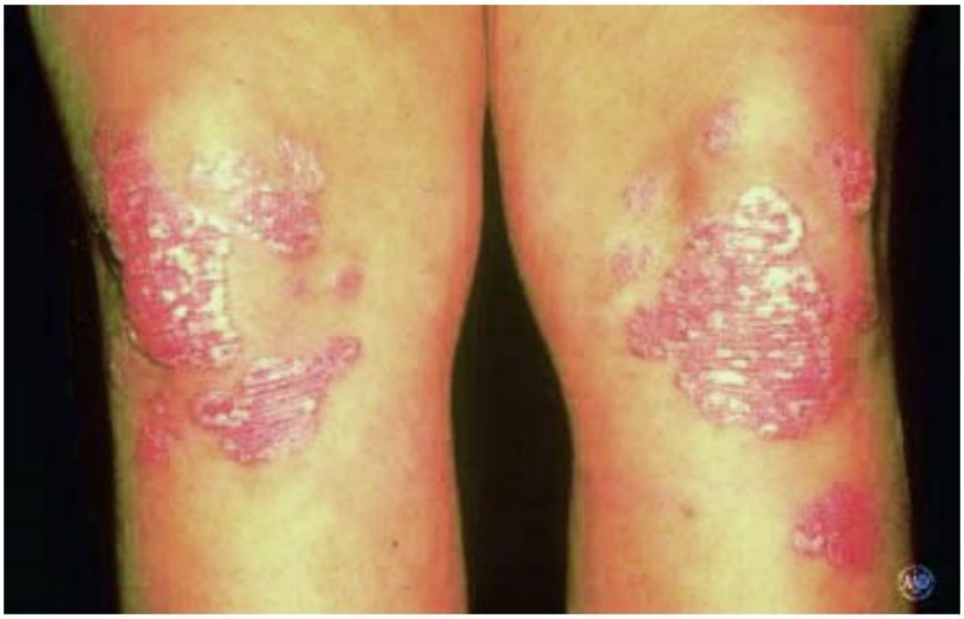
a. Candidiasis genital
b. Liquen escleroso
c. Dermatitis de contacto alérgica
d. Dermatitis de contacto irritativa
e. Cáncer espinocelular

Respuesta correcta: b. Liquen escleroso

Explicación: Es un liquen escleroso o escleroatrófico clásico: lesión pruriginosa, blanquecina o eritematosa, atrófica en la mucosa perivulvar, perianal o en el pene y prepucio. La candidiasis afecta la mucosa principalmente y tiene una leucorrea en “leche cortada” y prurito. La dermatitis de contacto alérgica también es un diagnóstico posible, pero sí afecta la mucosa, además de la piel, y por otro lado el cuadro clínico es característico del liquen escleroso.

Fuente: Dermatología, cuestionario 4.4, P11

25. Un paciente presenta aparición de lesiones eritematosas, con descamación blanca sobre las rodillas, como se aprecia en la fotografía: El diagnóstico más probable es:



a. Psoriasis
b. Liquen simple crónico
c. Liquen plano
d. Dermatitis atópica
e. Dermatitis seborreica

Respuesta correcta: a. Psoriasis

Explicación: Es una psoriasis clásica: placas eritematosas en las rodillas.

Fuente: Dermatología, cuestionario 4.5, P18

26. Un paciente consulta por lesiones recidivantes, muy pruriginosas en las muñecas y antebrazos, como muestra la foto: El diagnóstico más probable es:

a. Verrugas planas
b. Dermatitis atópica
c. Molusco contagioso
d. Liquen plano
e. Liquen simple crónico

Respuesta correcta: d. Liquen plano

Explicación: Es un liquen plano clásico.

Fuente: Dermatología, cuestionario 4.6, P2

27. Una mujer consulta por prurito vulvar. Al examen físico se aprecia que la mucosa vaginal está indemne, sin embargo, la piel circundante es pálida, algo eritmatosa y lisa, con signos de grataje. El diagnóstico más probable es:



a. Liquen plano
b. Liquen escleroso
c. Candidiasis genital

d. Dermatitis de contacto
e. Dermatitis atópica

Respuesta correcta: b. Liquen escleroso

Explicación: Es un liquen escleroso clásico.

Fuente: Dermatología, cuestionario 4.6, P3

28. Un paciente de 23 años consulta por aparición de múltiples lesiones en el tronco y la zona proximal de las extremidades, que inició hace una semana. Las lesiones consisten en placas rosadas, con una fina y escasa descamación. No duelen y se aprecian especialmente en la espalda y pecho. El diagnóstico más probable es:

a. Pitiriasis versicolor
b. Pitiriasis rosada
c. Sífilis secundaria
d. Psoriasis
e. Urticaria

Respuesta correcta: b. Pitiriasis rosada

Explicación: Es una pitiriasis rosada clásica. La placa más grande, probablemente es la mancha heráldica.

Fuente: Dermatología, cuestionario 4.6, P4

Acné y rosácea (9)

29. Un paciente de 56 años presenta pápulas y pústulas que comprometen la cara. Además presenta eritema y descamación de los párpados y ha presentado varios chalaziones en el último tiempo. El diagnóstico más probable es:

a. Lupus discoide
b. Lupus eritematoso sistémico
c. Acné
d. Rosácea
e. Dermatitis atópica

Respuesta correcta: d. Rosácea

Explicación: Es una rosácea clásica (pápulas y pústulas sobre una base eritematosa en la cara, sin comedones), con el compromiso ocular clásico (hace blefaritis, chalaziones y queratitis). El manejo incluye: 1. evitar los desencadenantes de eritema (ej. comidas, cambios de temperatura, alcohol) y usar bloqueador solar, 2. Manejo del eritema con vasoconstrictores tópicos (actualmente se usa la brimonidina), 3. para las telangiectasias, se puede usar tratamiento láser, 4. Para las pústulas y pápulas, se recomienda el metronidazol tópico (no se sabe bien cómo funciona) o la doxiciclina oral. 5. Los casos severos, se tratan con isotretinoína o láser.

Fuente: Dermatología, cuestionario 4.1, P9

30. Un paciente de 18 años presenta pápulas y pústulas en el pecho y espalda, asociado a comedones. El diagnóstico más probable es:

a. Pitiriasis versicolor
b. Varicela
c. Acné

d. Prúrigo
e. Foliculitis

Respuesta correcta: c. Acné

Explicación: La presencia de comedones hace el diagnóstico de acné, de manera inmediata. Además, la ubicación más frecuente de las lesiones es cara, pecho y espalda. El prúrigo se caracteriza por vesículas y pápulas pruriginosas, que suelen aparecen en las extremidades y tronco, luego de picaduras de insectos o de exposición a algunas plantas. Es más frecuente en niños. La foliculitis sí tiene pústulas, en relación a los folículos pilosos, pero sin comedones.

Fuente: Dermatología, cuestionario 4.2, P15

31. Un paciente de 17 años presenta múltiples pústulas y pápulas en cara, pecho y espalda, que en los últimos días han aumentado en cantidad, formándose nódulos inflamatorios confluentes, apareciendo además fiebre alta. En sus exámenes destaca leucocitosis importante, con predominio de neutrófilos. El diagnóstico es:

a. Erupción neutrofílica febril
b. Acné fúlminas
c. Erisipela
d. Celulitis
e. Antrax cutáneo

Respuesta correcta: b. Acné fúlminas

Explicación: Tiene un acné fúlminas clásico: acné severo, con síntomas sistémicos (fiebre, leucocitosis, etc.). El tratamiento de elección, actualmente son los corticoides (ej. prednisona) más isotretinoína. Los antibióticos, como la tetraciclina, se han usado históricamente, pero no queda clara su real utilidad y algunos estudios sugieren que podrían tener menor respuesta, por lo que no se recomiendan como primera línea, sino solo si no responde o hay signos sugerentes de sobreinfección. Cuando solo tiene los nódulos inflamatorios confluentes, pero sin los síntomas sistémicos, se llama acné conglobata y se trata con isotretinoína. - La erupción neutrofílica febril, o síndrome de Sweet, se caracteriza por fiebre, leucocitosis y placas eritematosas y dolorosas en distintas zonas del cuerpo. Se produce en contexto de leucemia mieloide aguda

Fuente: Dermatología, cuestionario 4.3, P6

32. Una paciente de 50 años presenta eritema facial desde hace algunos meses, en especial cuando consume alcohol. En el último tiempo nota aparición de pápulas y pústulas en las mejillas. El diagnóstico más probable es:

a. Rosácea
b. Lupus eritematoso sistémico
c. Lupus discoide (lupus cutáneo subagudo)
d. Dermatomiositis
e. Acné

Respuesta correcta: a. Rosácea

Explicación: Es una rosácea clásica (eritema con pápulas y pústulas en la cara). El alcohol es uno de los desencadenantes clásicos (junto a los cambios de temperatura, la exposición solar y los condimentos). El lupus sistémico puede tener síntomas similares, pero afecta a personas más jóvenes y no tiene mucha relación con el alcohol, pero sí con la exposición solar.

Fuente: Dermatología, cuestionario 4.3, P20

33. Una paciente de 40 años consulta por eritema facial, asociado a aparición de múltiples pápulas y pústulas, localizadas en la frente, mejillas y nariz. Además, se aprecian algunas telangiectasias faciales, sin presencia de comedones. El tratamiento de primera línea es:

a. Metronidazol tópico
b. Peroxido de benzoílo tópico
c. Betametasona tópica
d. Mupirocina tópica
e. Cefadroxilo oral

Respuesta correcta: a. Metronidazol tópico

Explicación: Se describe una rosácea clásica. El manejo incluye: 1. evitar los desencadenantes de eritema (ej. comidas, cambios de temperatura, alcohol) y usar bloqueador solar, 2. Manejo del eritema con vasoconstrictores tópicos (actualmente se usa la brimonidina), 3. para las telangiectasias, se puede usar tratamiento láser, 4. Para las pústulas y pápulas, se recomienda el metronidazol tópico (no se sabe bien cómo funciona, pero es el fármaco más eficaz y algunos creen que lo hace disminuyendo del ácaro démodex) o la doxiciclina oral. 5. Los casos severos, se tratan con isotretinoína o láser.

Fuente: Dermatología, cuestionario 4.4, P17

34. Paciente de 16 años, sin antecedentes, consulta por aparición de lesiones en su frente. Al examen físico se aprecian comedones en su rostro, asociados a pápulas y algunas pústulas en la frente, sin otros hallazgos. La conducta más adecuada es:

a. Corticoides orales y metronidazol tópico
b. Queratinolíticos tópicos y corticoides tópicos
c. Queratinolíticos tópicos e isotretinoina oral
d. Antibióticos orales y puvaterapia
e. Queratinolíticos tópicos y antibióticos tópicos

Respuesta correcta: e. Queratinolíticos tópicos y antibióticos tópicos

Explicación: Tiene un acné comedoniano y pápulo-pustular. Actualmente se ha estudiado más en detalle múltiples fármacos en el tratamiento del acné. Los queratolíticos, en especial, los retinoides tópicos (ej. adapaleno, tretinoína, tazaroteno) son el tratamiento de primera línea, de elección, en el acné únicamente comedoniano. Como alternativas están el ácido azelaico y el ácido salicílico solos. Si no responde o si es acné inflamatorio (con pústulas y pápulas, como en este caso), se primera línea se indica un retinoide más un antimicrobiano tópico (ej. peróxido de benzoílo o clindamicina). En los casos más graves, se pueden usar terapias sistémicas, tales como la isotretinoína oral (fármaco que cambia el curso de la enfermedad y logra remisión a largo plazo, pero reseca mucho la piel y labios, además de tener reacciones adversas tales como hepatitis y reacciones fototóxicas) y, en casos seleccionados, los antibióticos orales, en especial las tetraciclinas, como la doxiciclina o la minociclina. También, en mujeres, pueden servir los anticonceptivos con progestinas antiandrogénicas como la drospirenona, dienogest o clormadinona. También podría servir la espironolactona, aunque tiene riesgo de hiperkalemia.

Fuente: Dermatología, cuestionario 4.5, P1

35. Una paciente consulta por ardor ocular, asociado a enrojecimiento de la cara. Al examen físico se aprecia eritema de los párpados y de las mejillas y frente, con abundantes pápulas y pústulas sobre las áreas eritematosas. El diagnóstico más probable es:

a. Dermatomiositis
b. Rosácea
c. Acné conglobata
d. Lupus eritematoso sistémico
e. Lupus cutáneo subagudo

Respuesta correcta: b. Rosácea

Explicación: Es una rosácea clásica, con la afectación ocular clásica. Además, no respeta el surco nasogeniano (afecta el mentón), por lo que no parece lupus.

Fuente: Dermatología, cuestionario 4.6, P14

36. El tratamiento de primera línea del acné comedoniano es:

a. Retinoides tópicos
b. Antibióticos orales
c. Antibióticos tópicos
d. Isotretinoína oral
e. Corticoides tópicos

Respuesta correcta: a. Retinoides tópicos

Explicación: Actualmente se ha estudiado más en detalle múltiples fármacos en el tratamiento del acné. Los retinoides tópicos (ej. adapaleno, tretinoína, tazaroteno) son el tratamiento de primera línea, de elección, en el acné únicamente comedoniano. Como alternativas están el ácido azelaico y el ácido salicílico solos. Si no responde o si es acné inflamatorio (con pústulas y pápulas), se primera línea se indica un retinoide más un antimicrobiano tópico (ej. peróxido de benzoílo o clindamicina). En los casos más graves, se pueden usar terapias sistémicas, tales como la isotretinoína oral (fármaco que cambia el curso de la enfermedad y logra remisión a largo plazo, pero reseca mucho la piel y labios, además de tener reacciones adversas tales como hepatitis y reacciones fototóxicas) y, en casos seleccionados, los antibióticos orales, en especial las tetraciclinas, como la doxiciclina o la minociclina. También, en mujeres, pueden servir los anticonceptivos con progestinas antiandrogénicas como la drospirenona, dienogest o clormadinona. También podría servir la espironolactona, aunque tiene riesgo de hiperkalemia.

Fuente: Dermatología, cuestionario 4.6, P15

37. Las alteraciones dermatológicas en la nariz del paciente, en la fotografía de más abajo, son una consecuencia de:

a. Dermatitis seborreica
b. Dermatitis atópica
c. Dermatomiositis
d. Rosácea
e. Lupus

Respuesta correcta: d. Rosácea

Explicación: Tiene una rinofima, que es la etapa final de la rosácea.

Fuente: Dermatología, cuestionario 4.6, P19

Infecciones bacterianas de la piel (11)

38. Un paciente se entierra una espina en la maño izquierda, evolucionado dos días después con eritema, aumento de volumen y dolor en la mano, asociado a fiebre hasta 38,5°C. Al examen se aprecia zona eritematosa de 6 cm de diámetro, con bordes poco claros, sin exudado. El diagnóstico más probable es:

a. Fasceítis necrotizante
b. Celulitis
c. Erisipela
d. Ectima
e. Impétigo

Respuesta correcta: b. Celulitis

Explicación: Como los bordes son poco claros (difusos), lo más probable es que sea una celulitis. La erisipela tiene bordes claros o nítidos. La fasceítis necrotizante tiene aspecto necrótico (áreas violáceas o negruzcas). Se trata con cloxacilina o cefalosporinas (clindamicina en alérgicos). Eso sí, si se sospecha SAMR (ej. hospitalización reciente) o si está grave (séptico), actualmente se recomienda dejar directamente vancomicina u otro fármaco, que cubra SAMR. - Si el paciente está bien y tiene una lesión pequeña, se puede indicar tratamiento oral. - Si, en cambio, está séptico, febril y decaído o con lesión de gran tamaño, se debe iniciar endovenoso. Si hubiese tenido bordes claramente definidos, sería una erisipela, que es causada por Streptococcus pyogenes (Grupo A), el que se trata de elección con penicilina G endovenosa. En alérgicos, de elección serán las cefalosporinas o, si están contraindicadas (ej. alergia a la penicilina mediada por IgE o severa), se usa la clindamicina. A modo de resumen y recordatorio: ¿Cómo matar a un Streptococcus pyogenes? Penicilina, amoxicilina, cloxacilina, flucloxacilina, cefalosporinas, clindamicina. ¿Cómo matar a un Staphilococcus aureus meticilino sensible? Cloxacilina, flucloxacilina, cefalosporinas, clindamicina. ¿Cómo matar a un Staphilococcus aureus meticilino resistente? Oral: Cotrimoxazol + rifampicina; Endovenoso: vancomicina, linezolid, daptomicina.

Fuente: Dermatología, cuestionario 4.1, P14

39. Un hombre de 23 años consulta porque luego de afeitarse, evoluciona con múltiples pústulas en la mejilla derecha, que luego se hacen confluente, dando origen a una masa de 5 cm, fluctuante, eritematosa, con varias pústulas en su superficie. El agente etiológico es:

a. Propionibacterium acnes
b. Pseudomona aureginosa
c. Streptococcus pyogenes
d. Anaerobios
e. Staphilococcus aureus

Respuesta correcta: e. Staphilococcus aureus

Explicación: Es una foliculitis aguda, que evoluciona a un ántrax cutáneo. Ambas son causadas por el S. aureus. El tratamiento de las foliculitis leves puede ser la observación o la aplicación de antibióticos tópicos (mupirocina o clindamicina), pero, cuando es muy extensa o no mejora, se trata con antibióticos que cubran S. aureus meticilino sensible (ej. cloxacilina, cefadroxilo). Sin embargo, cuando evoluciona a un antrax, es necesario drenarlo quirúrgicamente y dar tratamiento antibiótico endovenoso.

Fuente: Dermatología, cuestionario 4.1, P20

40. Un niño presenta lesiones costrosas en la zona perioral e infranasal, que aprecieron hace 24 horas. Al examen se aprecia eritema y costras claras en las zonas descritas. El diagnóstico más probable es:

a. Síndrome de Steven Johnson
b. Impétigo
c. Escarlatina
d. Ectima
e. Dermatitis de contacto

Respuesta correcta: b. Impétigo

Explicación: Es un impétigo clásico, con las costras mielicéricas características. Se puede tratar con antibióticos orales o tópicos. Además, se suele "descostrar" con un paño húmedo, de manera cuidadosa. Se prefieren los orales cuando son lesiones muy extensas o cuando no responde al tratamiento tópico. Por ser una patología generalmente leve, no es necesario cubrir SAMR, a menos que no responda y se aísle dicho patógeno. Tratamiento tópico: mupirocina o furazolidona. Tratamiento oral: cefadroxilo, flucloxacilina, cloxacilina e incluso amoxicilina + ácido clavulánico. Si es por SAMR: clindamicina o cotrimoxazol oral.

Fuente: Dermatología, cuestionario 4.2, P4

41. Un paciente presenta una placa eritematosa de 15 cm de diámetro mayor en la pierna izquierda, con bordes difíciles de definir. Sus signos vitales son normales. El tratamiento más adecuado es:

a. Cloxacilina endovenosa
b. Penicilina endovenosa
c. Vancomicina endovenosa
d. Clindamicina endovenosa
e. Cefadroxilo oral

Respuesta correcta: a. Cloxacilina endovenosa

Explicación: Es una celulitis clásica, ya que tiene bordes difusos. Se debe cubrir estafilococo aureus. En los casos graves o con factores de reisgo, actualmente se recomienda cubrir de entrada al SAMR (si hipotenso, taquicárdico, fiebre alta, lesiones abscedadas, rápida progresión, paciente recientemente hospitalizado o con uso reciente de fármacos antiestafilocócicos, inmunodeprimidos, etc.). Suele tratarse por vía endovenosa, con cloxacilina o cefazolina (clindamicina en alérgicos). Solo cuando lleva la menos 2 días afebril, bajo antibióticos y la lesión va en retroceso, se puede cambiar el tratamiento a vía oral, con cefadroxilo, flucloxacilina o cloxacilina. Si se debe cubrir SAMR, se indica vancomicina endovenosa.

Fuente: Dermatología, cuestionario 4.2, P8

42. Un niño de 8 meses de edad, sin antecedentes de importancia, presenta en las últimas 24 horas, fiebre y aparición de múltiples vesículas y bulas generalizadas que se hacen confluentes y se rompen con facilidad, dejando una importante superficie de la superficie corporal expuesta. El diagnóstico más probable es:

a. Síndrome de piel escaldada
b. Pénfigo
c. Penfigoide
d. Necrosis epidermotóxica
e. Síndrome de Steven Johnson

Respuesta correcta: a. Síndrome de piel escaldada

Explicación: Es un síndrome de piel escaldada clásico (se abrevia como SSSS por su nombre en inglés), tanto por la edad (lactantes), como por la clínica: aparece eritema y luego vesículas, pústulas y bulas, que se rompen fácil, dejando zonas de piel sin epidermis. Además tiene Nikolsky (+): se desprende la epidermis al traccionarla, ya que la toxina exfoliativa ataca la unión interqueratinocito. El diagnóstico es clínico (aunque sí es aceptable cultivar la zona en la que se sospecha se aloja la infección estafillocócica, para conocer el antibiograma). El tratamiento suele ser hospitalizado, con manejo de las heridas, soporte y antibióticos antiestafilocócicos (cloxacilina endovenosa o cefalosporinas de primera generación, como cefazolina). La clindamicina se puede agregar y, de hecho, algunos la recomiendan por su efecto en reducir la producción de toxinas (aunque no tiene mayor evidencia clínica). La vancomicina es una opción, pero, por ahora, la gran mayoría de los SSSS son por S. aureus meticilino sensible. - El pénfigo y penfigoide son enfermedades autoinmunes crónicas, con vesículas recidivantes. El pénfigo tiene ampollas fáciles de romper y signo de Nikolsky (anticuerpos contra la unión interqueratinocito). El penfigoide, en cambio, tiene ampollas tensas, difíciles de romper y no tiene signo de Nikolsky, ya que los anticuerpos atacan la lámina basal, manteniéndose los queratinocitos unidos en una capa fuerte. - La NET y el SSJ son reacciones a fármacos y suelen ser muy graves, con importante afectación de mucosas y compromiso cutáneo. La NET tiene Nikolsky; el SSJ, no.

Fuente: Dermatología, cuestionario 4.3, P5

43. Un niño de 3 años presenta lesiones costrosas, amarillentas alrededor de la boca, que aparecieron hace 2 días y han aumentado. El diagnóstico más probable es:

a. Impétigo
b. Ectima
c. Erisipela
d. Escarlatina
e. Dermatitis seborreica

Respuesta correcta: a. Impétigo

Explicación: Es un impétigo vulgar clásico, con las costras mielicéricas peribucales y perinasales. El ectima es similar, pero ulcerado (llega a la dermis y deja cicatriz). La erisipela es una placa roja, de bordes definidos. La escarlatina es un exantema papular, áspero, con especial compromiso de pliegues cubitales y poplíteos, asociado a una amigdalitis u otra infección estreptocócica. La dermatitis seborreica afecta el cuero cabelludo, la zona nasal y las cejas, con descamación amarillenta.

Fuente: Dermatología, cuestionario 4.3, P17

44. Un paciente presenta fiebre y aparición de una placa eritematosa en la pierna izquierda, de 10 cm de diámetro y bordes claramente visibles, asociado a presencia de un cordón eritematoso que asciende por el muslo. El tratamiento de elección es:

a. Ceftriaxona endovenosa
b. Penicilina endovenosa
c. Cloxacilina endovenosa
d. Vancomicina endovenosa
e. Clindamicina endovenosa

Respuesta correcta: b. Penicilina endovenosa

Explicación: Se describe una erisipela (bordes nítidos), con una linfangitis. Es causada por Streptococcus pyogenes, por lo que se trata con penicilina o ampicilina endovenosa. En alérgicos, se usan las

cefalosporinas (salvo en alergias severas y/o mediadas por IgE) o la clindamicina. La cloxacilina también lo cubre, pero se prefiere la penicilina, por tener un espectro más acotado.

Fuente: Dermatología, cuestionario 4.3, P19

45. Un paciente de 35 años presenta un cuadro de fiebre, asociado a aparición de una placa eritematosa en la pierna derecha. Al examen se aprecia la placa sensible, de 15 cm de diámetro mayor, de bordes nítidos, asociada a un cordón eritematoso que asciende por el muslo. La conducta más adecuada es:

a. Solicitar resonancia magnética nuclear
b. Iniciar cloxacilina endovenosa
c. Iniciar penicilina endovenosa
d. Iniciar amoxicilina oral
e. Iniciar prednisona oral

Respuesta correcta: c. Iniciar penicilina endovenosa

Explicación: Se describe una erisipela (bordes nítidos), con una linfangitis. Es causada por Streptococcus pyogenes, por lo que se trata con penicilina o ampicilina endovenosa. En alérgicos, se usa la clindamicina o cefalosporinas como la cefazolina (salvo que tenga reacciones severas o por IgE, que sí contraindican el uso de cefalosporinas). La cloxacilina también lo cubre, pero se prefiere la penicilina, por tener un espectro más acotado. Si hubiese tenido mucho dolor o bulas hemorrágicas, podría haber sido una fasceítis necrotizante inicial, por lo que se tendría que estudiar con la resonancia magnética nuclear.

Fuente: Dermatología, cuestionario 4.4, P8

46. Un paciente presenta fiebre alta, asociada a parición de una lesión de gran tamaño en el muslo derecho, muy dolorosa y con zona violáceas y negruzcas, como se aprecia en la fotografía. La conducta más adecuada es:



a. Iniciar penicilina + cloxacilina endovenosa

b. Solicitar resonancia magnética nuclear y decidir conducta según hallazgo
c. Solicitar ecografía y decidir conducta según hallazgo
d. Administrar penicilina + clindamicina endovenosas y realizar debridación quirúrgica de inmediato
e. Administrar antibióticos de amplio espectro por vía endovenosa, asociado a corticoides sistémicos en altas dosis

Respuesta correcta: d. Administrar penicilina + clindamicina endovenosas y realizar debridación quirúrgica de inmediato

Explicación: Tiene una fascitis necrosante o fasceítis necrotizante tipo II (monomicrobiana, clásica de inmunocompetentes). Es causada por Streptoccus pyogenes o Estreptococo grupo A (SGA). Se trata con antibióticos endovenosos más debridación quirúrgica urgente. El antibiótico de elección para el SGA es la penicilina y en las infecciones graves (ej. shock tóxico o fasceítis), se recomienda agregar clindamicina. Por eso, en este caso, se debe dejar penicilina sódica más clindamicina endovenosa. El diagnóstico es clínico y se confirma con la exploración quirúrgica. La RMN puede servir para confirmarla, siempre que exista duda y no retrase la cirugía (en este caso está clarísimo).

Fuente: Dermatología, cuestionario 4.4, P19

47. Un adolescente presenta aparición de lesiones en la cara, desde hace 3 días, las que han aumentado. Al examen físico se aprecia lo siguiente: El diagnóstico más probable es:



a. Acné
b. Rosácea
c. Erisipela

d. Impétigo
e. Ántrax

Respuesta correcta: d. Impétigo

Explicación: Es un impétigo clásico, con las costras mielicéricas. Se trata con descostraje con un paño húmedo y antibióticos tópicos (mupirocina, clindamicina, polimixina B). En los casos con más lesiones, que no responden o en los que el paciente no copera con el tratamiento tópico, se trata con antibióticos orales (cloxacilina, flucloxacilina o cefadroxilo). Por ser una enfermedad leve, no es necesario cubrir SAMR de entrada.

Fuente: Dermatología, cuestionario 4.5, P20

48. Un paciente presenta fiebre, asociada a una lesión eritematosa en la pierna izquierda. Al examen físico se aprecia una placa eritematosa, brillante, de 12 x 20 cm de diámetro, con aumento de la temperatura local. El tratamiento más adecuado para este paciente es:



a. Cefadroxilo oral
b. Ceftriaxona endovenosa
c. Cloxacilina endovenosa
d. Clindamicina endovenosa
e. Penicilina endovenosa

Respuesta correcta: e. Penicilina endovenosa

Explicación: Es una erisipela, por lo que se trata de elección con penicilina endovenosa. El borde es fácil de definir.

Fuente: Dermatología, cuestionario 4.6, P7

Micosis superficiales (7)

49. Un paciente presenta máculas hipopigmentadas en la espalda, especialmente en la zona central. No ha tenido otros síntomas y presenta leve descamación al raspar la lesión con una pinza. El diagnóstico más probable es:

a. Micosis fungoide
b. Tiña corporis
c. Pitiriasis versicolor
d. Vitíligo

e. Pitiriasis alba

Respuesta correcta: c. Pitiriasis versicolor

Explicación: Es una pitiriasis versicolor clásica: máculas hipopigmentadas en pecho y espalda, con signo del uñetazo (descaman al rasparlas). El tratamiento suele ser con antimicóticos tópicos (champú de ketoconazol o terbinafina tópica). En los casos severos o refractarios se usan antimicóticos orales (fluconazol o itraconazol son de elección). Las recurrencias son frecuentes, por lo que es importante educar en evitar el sudor y bañarse después de hacer ejercicio e, incluso, se puede indicar champú de ketoconazol una vez al mes, como profilaxis. - La micosis fungoide es un linfoma cutáneo crónico, que inicia como máculas hiperpigmentadas o eritematosas, evoluciona a placas y luego a tumores, en un tiempo de años. - El vitíligo son máculas acrómicas en cara, extremidades, genitales y axilas y luego se pueden extender a otros lugares. - La pitiriasis alba también tienen máculas hipoogmentadas y sí puede descamar, pero se localiza en la cara y en los hombros y se asocia atopía.

Fuente: Dermatología, cuestionario 4.1, P6

50. Un paciente de 12 años presenta una zona de alopecia en el cuero cabelludo, caracterizado por una placa eritematosa, con descamación, levemente pruriginosa, observándose algunos cabellos quebrados. La conducta más adecuada es:

a. Iniciar antimicóticos tópicos
b. Iniciar corticoides tópicos
c. Iniciar antimicóticos orales
d. Iniciar antibióticos tópicos
e. Observar evolución

Respuesta correcta: c. Iniciar antimicóticos orales

Explicación: Es una tiña capitis clásica: placa alopécica en el cuero cabelludo, con signos inflamatorios, descamación y pelos quebrados (a diferencia de la alopecia areata que no tiene pelos ni signos inflamatorios). La griseofulvina oral es el tratamiento de elección para la tiña capitis, causada por el Microsporum canis. Es mejor que la terbinafina para el microsporum. Es importante que el tratamiento debe ser oral, a diferencia de algunas otras tiñas. En el caso de la tiña tricofítica (menos frecuente), se puede usar tanto la griseofulvina como la terbinafina (esta última será una opción aceptable si es que se confirma que el agente es un Trichophyton.

Fuente: Dermatología, cuestionario 4.1, P19

51. Un hombre de 25 años consulta por “hongos en los pies”. Al examen físico se aprecia hiperqueratosis y descamación de la piel interortejo y algunas zonas de la planta, sin compromiso ungueal. La conducta más adecuada es:

a. Observar evolución
b. Iniciar griseofulvina oral
c. Iniciar terbinafina tópica
d. Iniciar fluconazol oral
e. Iniciar itraconazol endovenoso

Respuesta correcta: c. Iniciar terbinafina tópica

Explicación: Tiene una tiña pedis, que suele ser por Trichophytom rubrum, por lo que se trata con antimicóticos tópicos. De elección la terbinafina, aunque puede servir el clotrimazol. - Si hubiese tenido compromiso ungueal (onicomicosis), el tratamiento tendría que haber sido oral, también con terbinafina.

Fuente: Dermatología, cuestionario 4.2, P11

52. Un paciente de 17 años presenta caída del cabello en un área de 5 cm en la cabeza. Al examen físico se aprecia una placa pruriginosa, descamativa, con algunos cabellos quebrados. El diagnóstico más probable es:

a. Alopecia areata
b. Psoriasis
c. Dermatitis seborreica
d. Tiña capitis
e. Lupus discoide

Respuesta correcta: d. Tiña capitis

Explicación: Es una tiña capitis clásica: placa alopécica descamativa, con signos inflamatorios y presencia de pelos quebrados. Se trata con griseofulvina oral, ya que suele ser por Microsporum canis. - La alopecia areata produce alopecia en un área, sin signos inflamatorios ni cabellos quebrados. - La psoriasis y la dermatitis seborreica afectan el cuero cabelludo, con eritema y descamación, pero sin alopecia. - El lupus discoide, cuando afecta el cuero cabelludo, produce alopecia permanente en el tiempo. Además suele afectar otras zonas fotoexpuestas (ej. Cara) y tiene placas eritematosas, que dejan cicatriz.

Fuente: Dermatología, cuestionario 4.2, P19

53. Un niño de 7 años presenta una lesión en cuero cabelludo, con escaso prurito. Al examen físico se aprecia una placa inflamatoria de 4 cm de diámetro, con caída de los pelos, y algunos pelos quebrados. ¿Qué tratamiento es más adecuado?

a. Corticoides tópico
b. Antibióticos tópicos
c. Griseofulvina oral
d. Terbinafina oral
e. Terbinafina tópica

Respuesta correcta: c. Griseofulvina oral

Explicación: Es una tiña capitis clásica (placa alopécica, inflamatoria con pelos quebrados). Se trata con griseofulvina oral de elección (cubre al Microsporum canis). La terbinafina oral es para la onicomicosis. La terbinafina tópica es de elección para la tiña corporis (también sirve el clotrimazol tópico). Si hubiese tenido una alopecia areata (sin signos inflamatorios ni pelo quebrados), los corticoides tópicos habrían sido la respuesta (aunque lo principal es el manejo del estrés).

Fuente: Dermatología, cuestionario 4.4, P9

54. Paciente de 26 años, sin antecedentes, consulta por caída de cabello, al examen físico se observa una placa alopécica de aproximadamente 2 cm de diámetro levemente eritematosa y con presencia de pelos quebradizos. El tratamiento de elección para este caso es:

a. Clotrimazol tópico
b. Terbinafina oral
c. Griseofulvina oral
d. Corticoides tópicos
e. Observación

Respuesta correcta: c. Griseofulvina oral

Explicación: Es una tiña capitis, la que se trata con griseofulvina, vía oral, puesto que curbe bien al Microsporum canis y es de elección. El fluconazol sí puede usarse, pero se prefiere para las infecciones por cándida y tiene evidencia algo más limitada. Si hubiese venido sin signos inflamatorios ni presencia de ningún cabello en el área afectada, sería una alopecia areata y el tratamiento habría sido correcto los corticoides tópicos o intralesionales, aunque si la pérdida de cabello es mayor al 50%, se debe derivar para tratamientos más complejos (ej. inhibidores JAK). Por ser autolimitada en muchos casos, si es pequeña y al paciente no le importa mayormente, se puede incluso observar.

Fuente: Dermatología, cuestionario 4.5, P2

55. La asociación de onicolisis y onicogrifosis en algunos ortejos de un paciente sin otros síntomas, es muy sugerente de:

a. Onicomicosis
b. Onicocriptosis
c. Psoriasis
d. Liquen plano
e. Sífilis

Respuesta correcta: a. Onicomicosis

Explicación: Onicolisis significa que la uña se despega parcialmente del lecho ungueal. Onicogrifosis es que la uña se vuelve gruesa. Ambos se ven en la onicomicosis. Onicocriptosis es un término técnico para referirse a la “uña encarnada”. La psoriasis sí puede tener esas cosas, pero lo más clásico son los pits o picotazos ungueales y las “manchas oleosas”.

Fuente: Dermatología, cuestionario 4.5, P14

Infecciones virales e infecciones de transmisión sexual (12)

56. Un paciente asintomático, se realiza varios exámenes, entre los que destacan Elisa VIH negativo y VDRL positivo, solicitados puesto que había tenido relaciones sexuales sin protección. La conducta más adecuada es:

a. Solicitar RPR
b. Repetir el VDRL
c. Solicitar MHA-TP (microhemaglutinación para Treponema pallidum)
d. Iniciar penicilina endovenosa
e. Indicar penicilina benzatina intramuscular

Respuesta correcta: c. Solicitar MHA-TP (microhemaglutinación para Treponema pallidum)

Explicación: Tiene un VDRL positivo, por lo que se debe confirmar con una prueba treponémica, como el MHA TP o el FTA ABS. - En los pacientes que ya tuvieron sífilis y fueron tratados con éxito (con normalización del VDRL), se trata directamente toda nueva elevación del VDRL, sin necesidad de confirmar con pruebas treponémicas, ya que resultan siempre alteradas. - Solo en los pacientes con clínica de sífilis primaria, se trata de inmediato, ya que los exámenes suelene estar negativos al inicio (igual se piden y se sigue con ellos). - En los pacientes con clínica de sífilis secundaria, embarazadas, sí se pide la prueba treponémica, pero se trata antes de tener el resultado. - El RPR puede usarse en lugar del VDRL, pero si uno de ellos está positivo, no es necesario pedir el otro, ya que son pruebas equivalentes.

Fuente: Dermatología, cuestionario 4.1, P10

57. Un paciente nota aparición de una pequeña lesión en el surco balanoprepucial, que no duele ni presenta prurito. Ha crecido lentamente en los últimos 3 meses, presentándose como una lesión polipoidea de cerca de 5mm de diámetro. El agente etiológico más probable es:

a. Virus herpes simplex
b. Treponema pallidum
c. Virus papiloma humano
d. Chlamydia trachomatis
e. Pox virus

Respuesta correcta: c. Virus papiloma humano

Explicación: Es un condiloma acuminado clásico, que es causado por el virus papiloma humano, serotipos 6 y 11.

Fuente: Dermatología, cuestionario 4.1, P16

58. ¿Cuál de los siguientes es un tratamiento adecuado para un paciente con gonorrea?

a. Penicilina benzatina intramuscular en una dosis
b. Ceftriaxona intramuscular en una dosis
c. Clindamicina oral por 10 días
d. Doxiciclina oral por 10 días
e. Metronidazol oral en una dosis

Respuesta correcta: b. Ceftriaxona intramuscular en una dosis

Explicación: El tratamiento de elección para la gonorrea es la ceftriaxona 250 mg IM por una vez (algunas recomendaciones internacionales prefieren 500 mg). - Como alternativa, se puede usar la azitromicina 2g oral, por una vez; el ciprofloxacino 500 mg oral por una vez; y la cefixima 800 mg oral, por una vez (cefalosporina de tercera generación oral). No sirven las cefalosporinas de primera y segunda generaciones. * Además, se debe dejar cobertura para Chlamydia trachomatis con doxiciclina 100 mg c/12 horas por 7-10 días o con azitromicina 1g vo por una vez. La coinfección es frecuente y la primera causa de falta de respuesta no es la resistencia, sino, precisamente, la coinfección con clamidia, que no se trata adecuadamente.

Fuente: Dermatología, cuestionario 4.2, P3

59. Un paciente presenta fiebre y un exantema generalizado. Como antecedente, relata múltiples parejas sexuales en el último tiempo, por lo que se decide solicitar un VDRL, que resulta positivo y un MHA-TP, que resulta negativo. La conducta más adecuada es:

a. Administrar penicilina benzatina 1,2 millones UI por una vez
b. Administrar penicilina benzatina 2,4 millones UI por 3 veces
c. Solicitar RPR
d. Solicitar microscopía de campo oscuro de una de las lesiones
e. Descartar la sífilis como diagnóstico, ya que se trata de un falso positivo

Respuesta correcta: e. Descartar la sífilis como diagnóstico, ya que se trata de un falso positivo

Explicación: Es una pregunta difícil, ya que tiene el exantema más el VDRL positivo, lo que suele ser indicación de tratamiento, mientras se confirma el diagnóstico con el MHA-TP. Sin embargo, dado que el MHA-TP está negativo, el diagnóstico es un falso positivo del VDRL y se debe buscar otra causa que explique el exantema y la fiebre.

Fuente: Dermatología, cuestionario 4.2, P14

60. Una paciente presenta fiebre, disuria y aparición de úlceras múltiples, en los labios vaginales, dolorosas, con tendencia a confluir. El agente etiológico más probable es:

a. Virus herpes simplex tipo 2
b. Virus papiloma humano
c. Haemophilus drucreyi
d. Treponema pallidum
e. Chlamydia trachomatis

Respuesta correcta: a. Virus herpes simplex tipo 2

Explicación: Es un herpes genital clásico: úlceras genitales múltiples, con fiebre y disuria. El diagnóstico suele ser clínico, aunque se puede objetivar con la PCR para virus herpes simplex (VHS), que ha desplazado a las técnicas más antiguas como el cultivo viral, dado que la PCR es actualmente más sensible que el cultivo. El tratamiento antiviral se recomienda tanto en el primer episodio (primoinfección) como las recurrencias, con aciclovir o valaciclovir oral. El valaciclovir tiene la ventaja de usarse solamente 2 veces al día, por lo que cada vez se prefiere más. Finalmente, la dosis de valaciclovir clásicamente ha sido de 500 mg c/12 horas por 5 a 7 días, pero, actualmente existen varias recomendaciones que sugieren usar 1 gramo cada 12 horas por 5-7 días. Mientras antes se inicie el tratamiento, menor es la tasa de recurrencias. - El virus papiloma produce condilomas acuminados. - El H. ducreyi produce el chancroide o chancro blando (úlcera única dolorosa). - El T. pallidum produce la sífilis (chancro: úlcera única indolora). - La Chlamydia trachomatis produce el linfogranuloma venéreo y la uretreitis no gonocócica.

Fuente: Dermatología, cuestionario 4.2, P20

61. El tratamiento de la uretritis no gonocócica es:

a. Ceftriaxona intramuscular
b. Doxicilina oral
c. Ciprofloxacino oral
d. Amoxicilina + ácido clavulánico oral
e. Metronidazol oral

Respuesta correcta: b. Doxicilina oral

Explicación: La uretritis no gonocócica suele ser causada por Chlamydia trachomatis y por Mycoplasma genitalium / Ureaplasma urealyticum. Todas se cubren con doxicilina por 10 días. Como alternativa sirve la azitromicina 1g por una vez, aunque muchas veces se tiene que agregar clindamicina, ya que puede haber resistencia en el Mycoplasma.

Fuente: Dermatología, cuestionario 4.3, P16

62. Un paciente de 45 años consulta por un exantema eritematoso descamativo, generalizado, con afectación de las palmas y plantas. Refiere haber tenido sífilis hace 5 años, la que trató exitosamente. ¿Qué examen es más adecuado para estudiarlo ahora?

a. Cultivo de una de las lesiones
b. PCR para T. pallidum
c. RPR
d. FTA-ABS
e. Elisa VIH

Respuesta correcta: c. RPR

Explicación: Tiene clínica de sífilis secundaria (exantema eritematodescamativa, con afectación de palmas y plantas). Lo habitual es que se inicie el estudio con una prueba no treponémica (VDRL o RPR) y si está positiva, se debe tratar (por tener clínica de sífilis secundaria), pero, además, se debe confirmar con una prueba treponémica (FTA-ABS y MHA-TP) para estar seguro (aunque ya se haya tratado). Sin embargo, en este caso, como ya tuvo sífilis, no sirven las pruebas treponémicas, ya que permanecen positivas de por vida. El Elisa VIH sí hay que pedirlo, porque si ha tenido 2 veces sífilis, es probable que tenga más enfermedades de transmisión sexual, pero, en este caso se está preguntando la sífilis.

Fuente: Dermatología, cuestionario 4.4, P15

63. Un paciente de 35 años consulta por disuria y malestar general, asociado a aparición de múltiples lesiones genitales, como las que se muestran en la fotografía. ¿Qué tratamiento es más útil para el tratamiento de este paciente?



a. Podofilino tópico

b. Aciclovir oral
c. Penicilina benzatina intramuscular
d. Azitromicina oral
e. Corticoides orales

Respuesta correcta: b. Aciclovir oral

Explicación: La imagen muestra un herpes genital, en su primoinfección (múltiples vesículas en genitales). Se trata con aciclovir o valaciclovir (también las recurrencias).

Fuente: Dermatología, cuestionario 4.4, P20

64. Paciente de 50 años, con antecedente de VIH en tratamiento irregular, consulta por aparición de lesiones en brazo derecho. Al examen físico presenta pequeñas pápulas eritematosas de aproximadamente 5mm de diámetro, con una pequeña excavación central. El agente causal de estas lesiones es:

a. Virus herpes simplex
b. Citomegalovirus
c. Virus herpes 8
d. Toxoplasma gondii
e. Virus pox

Respuesta correcta: e. Virus pox

Explicación: Es un molusco contagioso clásico, que es causado por el virus pox. El virus herpes 8 produce el sarcoma de Kaposi.

Fuente: Dermatología, cuestionario 4.5, P10

65. Un niño de 5 años presenta, desde hace meses, pápulas indoloras en el dorso de los dedos y las manos, que en ocasiones presentan prurito escaso. Además, han aparecido nuevas lesiones similares, en la cara y en un antebrazo, siguiendo un patrón de distribución lineal. El diagnóstico más probable es:





a. Liquen plano
b. Liquen simple crónico
c. Fenómeno de Köebner
d. Verrugas planas
e. Dermatitis atópica

Respuesta correcta: d. Verrugas planas

Explicación: Es una pregunta difícil, ya que hace falta una imagen para estar seguro. Sin embargo, la distribución lineal y la cronicidad de las lesiones es muy sugerente de las verrugas planas, que suelen afectar en especial la zona peribucal y perioral, más las manos y antebrazos. - El liquen plano tiene pápulas en muñecas y tobillos. El liquen simple crónico tiene una placa pruriginosa y liquenificada. - El fenómeno de Köebner es aquel en que, al golpearse en una zona de la piel, aparecen lesiones similar al de otra enfermedad cutánea que el paciente tiene (ej. el paciente tiene psoriasis o vitíligo y al golpearse, le aparece la psoriasis o vitíligo en la zona del trauma). Sí es frecuente que tenga disposición lineal. Algunas imágenes de verrugas planas: Fuente: https://clinicaalova.com/tratamientos/dermatologia/verrugas-y-molluscum/ Fuente: https://dermatologiaclinica.es/enfermedad/verrugas-planas/

Fuente: Dermatología, cuestionario 4.5, P11

66. Un paciente consulta por aparición de una lesión en el pene. No refiere dolor ni otros síntomas y al examen físico se aprecia lo siguiente: El agente etiológico más probable es:

a. Treponema pallidum
b. Haemophilus ducreyi
c. Virus herpes simplex
d. Virus papiloma humano
e. Neisseria gonorreae

Respuesta correcta: a. Treponema pallidum

Explicación: Es una sífilis primaria o chancro clásico, por lo que es causada por el T. pallidum. Si bien se deben solicitar pruebas treponémicas y no treponémicas, el manejo más importante es tratar de inmediato, ya que suele tener dichas pruebas negativas al inicio y el resultado no cambiará la conducta. Por eso se dice que el diagnóstico de la sífilis primaria es clínico. Luego se seguirá con títulos de VDRL (deberían subir y luego bajar).

Fuente: Dermatología, cuestionario 4.6, P8

67. Un paciente consulta por aparición de una lesión en la planta del pie izquierdo, que le produce dolor al pisar. Al examen físico se aprecia una tumoración de 8 mm de diámetro, hiperqueratósica, con algunos puntos negros en su superficie. Además, se aprecia una lesión similar, pero de solo 4 mm en la misma planta del pie. El diagnóstico más probable es:



a. Verruga plantar
b. Melanoma acral
c. Queratosis actínica
d. Queratosis seborreica
e. Granuloma piógeno

Respuesta correcta: a. Verruga plantar

Explicación: Es una verruga plantar clásica, con la hiperqueratosis y los puntos negros clásicos (vasos trombosados).

Fuente: Dermatología, cuestionario 4.6, P9

Parasitosis cutáneas y picaduras (7)

68. Un niño de 6 años presenta prurito generalizado, de 2 semanas de evolución, que ha ido en aumento. Al examen físico se aprecia pápulas, costras y signos de rasquido en el abdomen, el área genital, las axilas y en las zonas interdigitales. El diagnóstico más probable es:

a. Dermatitis herpetiforme
b. Dermatitis de contacto alérgica
c. Dermatitis atópica
d. Escabiosis
e. Hidrosadenitis

Respuesta correcta: d. Escabiosis

Explicación: Es una sarna o escabiosis clásica, con tendencia a ubicarse en pliegues, abdomen y zona interdigital. El diagnóstico suele ser clínico, pero se sugiere confirmarlo con un ácaro test. El tratamiento de elección es con permetrina tópica al 5%, siendo una alternativa la ivermectina oral. En los casos en que se forma una costra (sarna noruega) se prefiere el uso combinado de ambos fármacos. La vaselina azufrada al 6% se ha recomendado en niños menores de 2-3 meses y en embarazadas y mujeres dando lactancia (así lo dice la guía ministerial que es antigua), pero la verdad es que la evidencia muestra que la permetrina es bastante segura en estos grupos y se puede dar sin problemas, siendo incluso recomendada como tratamiento de primera línea, por varias guías internacionales. - La dermatitis herpetiforme se caracteriza por vesículas pruriginosas en las zonas extensoras. - La dermatitis atópica se ubica en pliegues cubitales y poplíteos. - La hidrosadenitis se caracteriza por nódulos y abscesos en las axilas (obstrucción e infección de las glándulas apocrinas).

Fuente: Dermatología, cuestionario 4.1, P13

69. El tratamiento de la sarna en los prescolares es:

a. Lindano tópico
b. Vaselina azufrada
c. Permetrina tópica
d. Sintomático
e. Ketoconazol tópico

Respuesta correcta: c. Permetrina tópica

Explicación: El tratamiento de elección de la sarna es la permetrina al 5%, en loción. La vaselina azufrada, de acuerdo a las recomendaciones chilenas, es de elección en los menores de 3 meses, en la lactancia y en el embarazo, aunque si falla (30% de fracasos), se debe indicar igualmente la permetrina. Además, muchas recomendaciones internacionales prefieren la permetrina, por ser segura en embarazo, lactancia (se lava antes de dar de mamar) y niños, aunque no existen estudios de seguridad en menores de 2 meses.

Fuente: Dermatología, cuestionario 4.3, P8

70. ¿Cuál es el tratamiento más adecuado para una mujer de 35 años diagnosticada de sarna?

a. Permetrina tópica al 5%
b. Permetrina tópica al 1%
c. Vaselina azufrada
d. Ivermectina oral

e. Lindano tópico

Respuesta correcta: a. Permetrina tópica al 5%

Explicación: El tratamiento de elección de la sarna es la permetrina al 5%, en loción. La guía chilena recomienda la vaselina azufrada en los menores de 3 meses, en la lactancia y en el embarazo, aunque si falla (30% de fracasos), se debe indicar igualmente la permetrina. Eso sí, la evidencia muestra que la permetrina es segura y más eficaz, por lo que muchas recomendaciones la ponen como tratamiento de primera línea en todos los casos. Los piojos se tratan con champú de permetrina al 1%.

Fuente: Dermatología, cuestionario 4.4, P16

71. Embarazada de 30 semanas, sin antecedentes, consulta por lesiones eritematosas en antebrazos, genitales, manos y tronco, asociadas a prurito. Al examen físico se aprecian lesiones eritematosas papulares y maculares en patrón sinuoso, con signos de grataje, por lo que se decide realizar un ácaro test, que resulta positivo. El tratamiento de elección, en este caso es:

a. Permetrina oral
b. Puvaterapia
c. Corticoides locales
d. DEET (N,N-diethil-m-toluamida)
e. Vaselina azufrada

Respuesta correcta: e. Vaselina azufrada

Explicación: Tiene una escabiosis o sarna, que suele tratarse con permetrina tópica, al 5%. Sin embargo, por estar embarazada, de acuerdo a la guía chilena, de elección es la vaselina azufrada y solo de segunda línea se indica la permetrina. Lo mismo sucede en la lactancia y en los menores de 3 meses. Sin embargo, la evidencia actual muestra que es segura la permetrina tópica en estos grupos (solo falta la evidencia en menores de 2 meses, pero probablemente sea segura en dicho grupo). Si le dieron permetrina oral, pues la pueden intoxicar severamente, ya que solo se da tópica. El DEET es el principio activo de la mayoría de repelentes con buena eficacia (idealmente concentraciones del 20% o más para que sea realmente eficaz).

Fuente: Dermatología, cuestionario 4.5, P12

72. El loxocelismo cutáneo se manifiesta clínicamente como:

a. Una mácula
b. Una úlcera
c. Una placa
d. Un nódulo
e. Un tumor

Respuesta correcta: c. Una placa

Explicación: La lesión clásica es la placa livedoide, que si bien puede estar ulcerada al centro, sigue siendo una gran placa, con varios colores concéntricos (rojo, blanco, violáceo y puede terne un centro negro o necrótico). Ejemplos de imágenes: Fuente: http://www.cenetec-difusion.com/ Fuente: wikipedia.

Fuente: Dermatología, cuestionario 4.5, P19

73. Un niño presenta lesiones vesiculares y papulares, que aparecieron hace 48 horas en las extremidades y el tronco. Al examen se aprecia lo siguiente: El diagnóstico más probable es:



a. Síndrome de Steven Johnson
b. Impétigo
c. Escarlatina
d. Varicela
e. Prúrigo

Respuesta correcta: e. Prúrigo

Explicación: Es un prúrigo clásico, tanto por la clínica (vesículas generalizadas, mayores en extremidades y tronco), como por la imagen. La varicela, en cambio, siempre afecta la cabeza y está precedida por un cuadro febril, con mialgias y malestar general.

Fuente: Dermatología, cuestionario 4.6, P11

74. Un niño de 4 años es diagnosticado de escabiosis en su colegio. El tratamiento más adecuado es:

a. Loción de permetrina
b. Ivermectina oral
c. Pomada de vaselina azufrada
d. Organofosforados tópicos
e. Antihistamínicos orales

Respuesta correcta: a. Loción de permetrina

Explicación: La permetrina al 5% es el tratamiento de elección de la sarna, excepto en embarazadas, lactancia y niños menores de 2-3 meses de edad, en que se prefiere la vaselina azufrada, según el Minsal. Sin embargo, las recomendaciones actuales en muchas guías internacionales es tratar con permetrina a embarazadas y nodrizas (sí se tienen que lavar el pezón antes de amamantar) y, en los niños pequeños,

menores de 2 meses, sí se deja la vaselina azufrada, por no existir estudio de seguridad, pero, si no responde a la vaselina azufrada, se indica permetrina igual.

Fuente: Dermatología, cuestionario 4.6, P18

Tumores cutáneos y lesiones premalignas (16)

75. Un paciente de 69 años presenta una lesión hiperqueratósica, irregular en la oreja izquierda, que en ocasiones sangra. Apareció hace 2 años y actualmente compromete gran parte del hélix. El diagnóstico más probable es:

a. Carcinoma basocelular
b. Carcinoma espinocelular
c. Dermatitis seborreica
d. Queratosis actínica
e. Queratosis seborreica

Respuesta correcta: b. Carcinoma espinocelular

Explicación: Tanto por la evolución, como porque sangra, lo más probable es que sea un cáncer. Además, está en una zona fotoexpuesta. Al describirse como hiperqueratósica, hace que lo más probable sea una cáncer espinocelular (también por la ulceración).

Fuente: Dermatología, cuestionario 4.1, P2

76. Un paciente de 60 años presenta una lesión en la espalda de 0,8 cm de diámetro, hiperpigmentada, de color heterogéneo y bordes irregulares. El diagnóstico más probable es:

a. Nevo atípico
b. Nevo melanocítico
c. Nevo de Ito
d. Nevo de spilus
e. Nevo de Sutton

Respuesta correcta: a. Nevo atípico

Explicación: Tiene varios signos de alarma: borde irregular, color heterogéneo y diámetro mayor a 6mm. Por tanto es nevo atípico, que debe resecarse y enviar a biopsia, para descartar un melanoma. La ubicación más frecuente de melanoma en hombres es la espalda y en mujeres, en las piernas, aunque realmente puede ocurrir en cualquier lugar, siendo más frecuente en las zonas que se han expuesto al sol y sufrido quemaduras solares.

Fuente: Dermatología, cuestionario 4.1, P11

77. Un paciente de 68 años presenta lesiones hiperpigmentadas en la frente, pómulos y tronco, caracterizadas por papulas hiperqueratósicas, de color café y bordes bien delimitados, con superficie untuosa, suave al tacto, con algunas pequeñas fisuras. El diagnóstico más probable es:

a. Nevo melanocítico
b. Melanoma
c. Léntigo solar
d. Queratosis seborreica
e. Queratosis actínica

Respuesta correcta: d. Queratosis seborreica

Explicación: Son queratosis seborreicas clásicas: lesiones rugosas e hiperpigmentadas, suaves al tacto. Los nevos, léntigos y melanoma suelen ser máculas y no son hiperqueratósicos. Las queratosis actínicas son eritemasosas y descamativa sy no son hiperpigmentadas. Además son ásperas al tacto.

Fuente: Dermatología, cuestionario 4.1, P15

78. Un paciente de 70 años consulta por una lesión negra en la cara, que ha crecido en el último tiempo. Refiere que apareció hace 4 años, como una pequeña mácula muy oscura, en la mejilla izquierda, pero que ha ido creciendo poco a poco. Actualmente se aprecia como una mácula hiperpigmentada, de color irregular, de 2 cm de diámetro. El diagnóstico más probable es:





a. Melanoma acral
b. Melanoma léntigo maligno
c. Léntigo solar
d. Queratosis seborreica
e. Carcinoma basocelular

Respuesta correcta: b. Melanoma léntigo maligno

Explicación: Es un léntigo maligno clásico: mácula hiperpigmentada de lento crecimiento, grande e irregular. El lugar más frecuente es en la cara y debe ser extirpado, ya que es un melanoma. Generalmente demora muchos años en profundizar, por lo que suele tener buen pronóstico. Sin embargo entre un 5% y un 20% evoluciona a melanoma invasivo, por lo que se recomienda extirparlos desde el diagnóstico. - Los melanomas acrales son los melanomas ubicados en zonas acrales (manos y pies), por lo que toda lesión hiperpigmentada en dichas zonas, debe ser evaluada por un dermatólogo. Imagen de ejemplo (fuente: https://www.pcds.org.uk/clinical-guidance/lentigo-maligna-melanoma-and-lentigo-maligna):

Fuente: Dermatología, cuestionario 4.2, P1

79. Un paciente de 69 años presenta una lesión de 1 cm de diámetro en la nariz, con borde levantado y brillante y una ulceración central. No duele ni presenta otros síntomas. La conducta más adecuada es:

a. Aplicar nitrógeno líquido
b. Aplicar corticoides tópicos
c. Observar evolución
d. Realizar biopsia por punción
e. Resecar quirúrgicamente y enviar a estudio anatomopatológico

Respuesta correcta: e. Resecar quirúrgicamente y enviar a estudio anatomopatológico

Explicación: Es un carcinoma basocelular clásico, por lo que debe ser removido y enviado a biopsia. Imagen referencial: Fuente: https://www.tuasaude.com/es/carcinoma-basocelular/

Fuente: Dermatología, cuestionario 4.2, P6

80. Un paciente de 60 años presenta una lesión eritematosa en el paladar duro, que no duele y que ha crecido lentamente en los últimos 2 años. Al examen físico de aprecia una placa eritematosa, de 2,5 cm de diámetro, de bordes irregulares. La conducta más adecuada es:

a. Iniciar antifúngicos tópicos
b. Solicitar exámenes para descartar lupus
c. Iniciar corticoides tópicos
d. Biopsiar la lesión
e. Observar evolución

Respuesta correcta: d. Biopsiar la lesión

Explicación: Tiene una eritroplaquia, que se debe biopsiar ya que puede tratarse de un cáncer espinocelular o de una lesión premaligna. Tiene mayor riesgo de ser o evolucionar a un cáncer invasor que la leucoplaquia.

Fuente: Dermatología, cuestionario 4.2, P18

81. Una paciente de 70 años presenta varias lesiones costrosas, indoloras, ubicadas en la frente y las orejas. Al examen físico se aprecias pequeñas placas de algunos milímetros de diámetro, eritematosas, hiperqueratósicas, secas, muy adherentes. El diagnóstico más probable es:

a. Dermatitis seborreica
b. Queratosis actínica
c. Carcinomas basocelulares
d. Carcinomas espinocelulares
e. Psoriasis

Respuesta correcta: b. Queratosis actínica

Explicación: Son queratosis actínicas clásicas: lesiones ásperas en zonas fotoexpuestas, caracterizadas por placas eritematosas e hiperqueratósicas pequeñas. Tienen riesgo de evolucionar a carcinoma espinocelular, por lo que se tratan con crioterapia. Si son múltiples y muy abundantes, después de la crioterapia de las lesiones más grandes, se suele indicar, además, fluorouracilo tópico. - La dermatitis seborreica tiene eritema y descamación amarillenta y puede afectar el cuero cabelludo, la zona perinasal y la zona ciliar (cejas), pero no las orejas y no se ve como pequeñas placas, sino como placas grandes. - Los carcinomas basocelulares se ven como lesiones de borde brillante (perlado), con telangiectasias adyacentes, úlcera central. - Los carcinomas espinocelulares suelen ser de mayor tamaño y tienen tendencia a ulcerarse. Además, es raro que sean múltiples, aunque puede ocurrir. - La psoriasis también tiene placas más grandes y la escama no es tan adherente.

Fuente: Dermatología, cuestionario 4.3, P3

82. ¿Cuál de las siguientes lesiones representa un mayor riesgo?

a. Nevo de Ito
b. Nevo congénito gigante
c. Nevo de Ota
d. Nevo de Spilus

e. Nevo de Sutton

Respuesta correcta: b. Nevo congénito gigante

Explicación: El nevo congénito gigante tiene altísimo riesgo de evolucionar a un melanoma, por lo que se debe extirpar. Las demás son lesiones sin mayor riesgo, salvo estético. El nevo de Sutton o nevo halo (tiene un área depigmentada alrededor) es frecuente en adolescentes y niños, como una única lesión. Eso sí, puede ser una reacción a un melanoma, así que, si el nevo central es atípico, si son múltiples o si se da en un adulto de edad avanzada, casos en los que se debe biopsiar.

Fuente: Dermatología, cuestionario 4.3, P10

83. Una mujer de 40 años consulta por una lesión hiperpigmentada, ubicada en la pierna derecha. Al examen físico se precia una lesión macular hiperpigmentada, de color heterogéneo y bordes irregulares, de 10 mm de diámetro. No presenta prurito, ni otros síntomas. La conducta más adecuada es:

a. Realizar biopsia excisional de la lesión
b. Realizar biopsia por punción
c. Indicar corticoides tópicos
d. Derivar a PUVA terapia
e. Observar evolución

Respuesta correcta: a. Realizar biopsia excisional de la lesión

Explicación: Tiene varios signos de alarma: color heterogéneo, bordes irregulares y más de 6 mm de diámetro, por lo que es un nevo atípico y se debe extirpar, por la posibilidad de que sea un melanoma. Si la biopsia demuestra un melanoma, se deben ampliar los márgenes (1 cm de margen si tiene una profundidad de menos de 1mm; 2 cm de margen si tiene una profundidad mayor de 1 mm). De todos modos, el manejo es resorte del especialista.

Fuente: Dermatología, cuestionario 4.3, P13

84. Un paciente de 48 años consulta por una lesión en la espalda. Refiere que ha crecido lentamente desde hace 2 años. Actualmente mide 1,5 mm. Ver foto: ¿Cuál es la conducta más adecuada?

a. Observar evolución
b. Indicar corticoide tópico
c. Realizar biopsia con dermatomo
d. Realizar biopsia excisional
e. Indicar crioterapia

Respuesta correcta: d. Realizar biopsia excisional

Explicación: La foto tiene aspecto de melanoma (irregular, de color heterogéneo, que ha crecido y que mide más de 6 mm). Sin embargo, hasta antes de la biopsia, el diagnóstico es un nevo atípico, que se debe biopsiar de manera excisional, para asegurar que no sea un melanoma. Si se confirma el melanoma, se deben ampliar los márgenes, hacer la biopsia de ganglio centinela y eventualmente indicar radioterapia, disección ganglionar e inmunoterapia.

Fuente: Dermatología, cuestionario 4.4, P5

85. Un paciente de 70 años consulta por una lesión solevantada en la nariz, caracterizada por tener un borde levantado y brillante y una depresión central, que ha crecido lentamente, llegando a un centímetro de diámetro en la actualidad. El diagnóstico más probable es:

a. Carcinoma espinocelular

b. Molusco contagioso
c. Queratosis seborreica
d. Carcinoma basocelular
e. Granuloma anular

Respuesta correcta: d. Carcinoma basocelular

Explicación: Es un cáncer basocelular clásico: lesión en zona fotoexpuesta, con borde perlado (brillante), depresión central. El cáncer espinocelular es hiperqueratósico. El molusco contagioso suele ser más de una lesión, con umbilicación central. El granuloma anular es una placa, que va creciendo, de borde papular y tendencia a la curación central, similar a una tiña corporis, pero sin afectación de los vellos ni descamación (porque es dérmico y no epidérmico). Se asocia a diabetes.

Fuente: Dermatología, cuestionario 4.4, P14

86. Un paciente de 65 años presenta 4 lesiones eritematosas e hiperqueratósicas en la frente, de un año de evolución, que no duelen ni presentan otros síntomas. Al examen se aprecian pequeñas lesiones algo solevantadas, de 3 a 5 mm de diámetro, muy ásperas al tacto. El diagnóstico más probable es:

a. Carcinoma basocelular
b. Carcinoma espinocelular
c. Queratosis actínica
d. Queratosis seborreica
e. Léntigos solares

Respuesta correcta: c. Queratosis actínica

Explicación: Son queratosis actínicas clásicas: placas pequeñas, indoloras, en zonas fotoexpuestas, hiperqueratósicas, muy adherentes y ásperas al tacto. Se tratan con crioterapia y, en casos que hay demasiadas lesiones, con fluorouracilo tópico. Los carcinomas suelen ser lesiones únicas (no siempre), más grandes. El basocelular no es hiperqueratósico, sino de borde brillante y ulceración. El espinocelular sí es hiperqueratósico y áspero, pero más grande y con tendencia a ulcerarse.

Fuente: Dermatología, cuestionario 4.4, P18

87. Paciente de 37 años, sin antecedentes, consulta por una lesión a nivel dorsal. Al examen físico se observa esta lesión hiperpigamentada de 5 mm de diámetro: La conducta más adecuada en este caso es:



a. Observar
b. Realizar biopsia excisional
c. Indicar radioterapia local
d. Indicar corticoides tópicos
e. Biopsiar el borde de la lesión

Respuesta correcta: a. Observar

Explicación: Es un nevo melanocítico común. No tiene ningún signo de alarma, ya que es pequeño, homogéneo, regular. Se debe observar.

Fuente: Dermatología, cuestionario 4.5, P3

88. Un paciente de 80 años presenta una lesión solevantada de 1 centímetro de diámetro, en la mejilla derecha, de bode brillante elevado, con una depresión central. El diagnóstico más probable es:

a. Cáncer espinocelular
b. Cáncer basocelular
c. Queratosis seborreica
d. Queratosis actínica
e. Léntigo maligno

Respuesta correcta: b. Cáncer basocelular

Explicación: Es un carcinoma basocelular clásico (borde perlado, ubicado en zona fotoexpuesta, en un adulto mayor). El tratamiento de elección es la resección quirúrgica con pequeño margen (4-5 mm y, si está en una zona importante estéticamente, incluso puede ser menor, con pequeñas resecciones con biopsias intraoperatorias, hasta que se confirmen los márgenes negativos, lo que se conoce como técnica de Mohs. - La queratosis seborreica es hiperpigmentada y de superficie irregular y agrietada, pero suave al tacto. - La actínica es hiperqueratósica y muy áspera. - El léntigo maligno es un tipo de melanoma, hiperpigmentado, irreguar y grande, que crece lento, habitualmente en la cara.

Fuente: Dermatología, cuestionario 4.5, P16

89. Un paciente de 65 años consulta por una lesión solevantada en la mano derecha, que ha crecido lentamente en los últimos dos años y se ha ulcerado en algunas ocasiones. Al examen físico se observa lo siguiente: El diagnóstico más probable es:

a. Queratosis seborreica
b. Queratosis actínica
c. Melanoma acral
d. Carcinoma basocelular
e. Carcinoma espinocelular

Respuesta correcta: e. Carcinoma espinocelular

Explicación: Es un cuerno cutáneo maligno, que es una forma de presentación del carcinoma epidermoide o espinocelular.

Fuente: Dermatología, cuestionario 4.6, P6

90. Un paciente de 69 años consulta por una lesión oscura en la cara, como la que se aprecia en la fotografía: El diagnóstico más probable es:



a. Carcinoma basocelular
b. Lentigo maligno
c. Melanoma acral
d. Lentigo solar
e. Queratosis seborreica

Respuesta correcta: b. Lentigo maligno

Explicación: Es un melanoma lentigo maligno o simplemente lentigo maligno clásico.

Fuente: Dermatología, cuestionario 4.6, P13

Enfermedades ampollares (4)

91. Una paciente de 65 años presenta lesiones ampollosas, recidivantes, que aparecen en el abdomen y en la cara flexora de las extremidades. Refiere que son pruriginosas y que no dejan cicatriz. Al examen físico se aprecian bulas tensas, difíciles de romper, en las zonas descritas, con compromiso de la mucosa oral. El diagnóstico más probable es:

a. Porfiria
b. Epidermolisis bulosa
c. Síndrome de piel escaldada
d. Pénfigo vulgar
e. Penfigoide ampolloso

Respuesta correcta: e. Penfigoide ampolloso

Explicación: Todas las enfermedades de las opciones producen ampollas. El penfigoide se caracteriza por ampollas tensas, difíciles de romper y compromiso frecuente de mucosas. Esto se debe a que los anticuerpos atacan la lámina basal, pero los queratinocitos se mantienen unidos, como una capa fuerte de epidermis. - La porfiria tiene hipertricosis de las cejas y ampollas en la cara. - La epidemolisis bulosa afecta a niños (por ser congénita): “niños con piel de cristal” y tiene síntomas similares al pénfigoide. - La piel escaldada también afecta a niños, tiene Nikolsjy (+) y tiene ampollas flácidas, que se instalan muy rápido, ya que la toxina exfoliativa del S. aureus ataca la unión interqueratinocito. - El pénfigo tiene ampollas flácidas, fáciles de romper, ya que los anticuerpos también atacan la unión interqueratinocitos.

Fuente: Dermatología, cuestionario 4.2, P13

92. Una paciente de 65 años presenta lesiones ampollares, recurrentes, distribuidas en la cara, tronco y extremidades, que se rompen fácilmente, que iniciaron hace cerca de un año, pero que han ido en aumento. Al examen, además es posible desprender la piel sana, al traccionarla con una presión moderada. El diagnóstico más probable es:

a. Pénfigo
b. Penfigoide
c. Porfiria cutánea
d. Síndrome de piel escaldada
e. Necrosis epidermotóxica

Respuesta correcta: a. Pénfigo

Explicación: Se describe un pénfigo clásico: lesiones ampollares fáciles de romper, con signo de Nikolsky (se desprende la epidermis al presionarla). El penfigoide no tiene Nikolsky y sus ampollas son tensas y difíciles de romper. La porfiria es muy rara en Chile y sí tiene ampollas, pero en zonas fotoexpuestas y

muchas veces tiene además hipertricosis facial. La piel escaldada es un cuadro agudo, con ampollas generalizadas y signo de Nikolsky, que afecta a lactantes. La NET también es un cuadro agudo con Nilolsky positivo, por exposición a fármacos.

Fuente: Dermatología, cuestionario 4.3, P12

93. Un paciente consulta por aparición de múltiples ampollas en el tronco y algunas en las extremidades. Al examen físico se aprecian dichas ampollas tensas, que no se rompen al presionarlas. El diagnóstico más probable es:

a. Pénfigo
b. Reacción fotoalérgica
c. Impetigo buloso
d. Penfigoide
e. Prúrigo

Respuesta correcta: d. Penfigoide

Explicación: Tiene un penfigoide clásico: ampollas tensas y difíciles de romper, con tendencia a la cronicidad y frecuentemente con afectación de las mucosas. Se trata con corticoides sistémicos y tópicos. La tetraciclina puede tener un efecto inmunomodulador. - El pénfigo tiene ampollas flácidas, fáciles de romper. El impétigo buloso también, con la diferencia que están localizadas en la zona de infección. - El prúrigo es una reacción pápulo-vesicular que se afecta extremidades y tronco, con prurito y que ocurre luego de picadura de insectos o de exposición a ciertas plantas.

Fuente: Dermatología, cuestionario 4.4, P7

94. Una paciente presenta aparición de ampollas generalizadas, que afecta tanto el tronco, como la cara y las extremidades. Las lesiones son dolorosas con un patrón de aparición crónico-recidivante. El signo de Nikolsky es positivo. El diagnóstico más probable es:

a. Epidermolisis bulosa
b. Prúrigo
c. Pénfigo
d. Penfigoide
e. Necrosis epidermotóxica

Respuesta correcta: c. Pénfigo

Explicación: El signo de Nikolsky solo está en 3 enfermedades: pénfigo, piel escaldada y necrosis epidermotóxica (NET). Además, la clínica crónica es sugerente de pénfigo, ya que la NET es un cuadro agudo, en razón a exposición a fármacos y la piel escaldada es agudo, en relación a una infección estafilocócica en lactantes.

Fuente: Dermatología, cuestionario 4.5, P15

Reacciones cutáneas a fármacos (6)

95. Un paciente de 44 años es diagnosticado de epilepsia, por lo que inicia tratamiento anticonvulsivante. Una semana después inicia con aparición de lesiones cutáneas generalizadas, dolorosas, que consisten en bulas con contenido hemorrágico, que se rompen, dejando grandes zonas expuestas. La piel sana se desprende al traccionarla, ejerciendo una presión moderada. El diagnóstico es:

a. Exantema multiforme menor
b. Síndrome de Steven Johnson

c. Necrosis epidérmica tóxica
d. Síndrome de piel escaldada
e. Penfigoide ampolloso

Respuesta correcta: c. Necrosis epidérmica tóxica

Explicación: Es una necrosis epidermolítica tóxica clásica, con el signo de Nikolsky (se desprende la epidermis). Es muy grave y se debe tratar en UCI, con ciclosporina, corticoides sistémicos, inmunoglobulina endovenosa (la inmunoglobulina no tiene mucha evidencia, eso sí), más el manejo de las lesiones cutáneas, oculares y de la vía aérea, indicando antibióticos ante la aparición de algún signo de infección (la primera causa de muerte es la sepsis). Eso sí, lo más importante para lograr la recuperación es suspender el fármaco que la desencadena. - El eritema multiforme menor y el síndrome de Steven Johnson sí pueden desencadenarse por los anticonvulsivantes, pero no tienen Nikolsky. El síndrome de Steven Johnson tiene un continuo con la NET, solo que menos severa. El manejo es similar, pero de mejor pronóstico. - El síndrome de piel escaldada y el pénfigo sí lo tiene, pero la piel escaldada afecta a niños y no tiene relación con los fármacos y el pénfigo es una enfermedad crónica, habitualmente sin relación a los fármacos (aunque sí existe todo tipo de reacciones cutáneas a fármacos, incluyendo el pénfigo y penfigoide por fármacos).

Fuente: Dermatología, cuestionario 4.1, P3

96. Un paciente de 25 años es hospitalizado por una neumonía ATS III, la que es manejada adecuadamente con antibióticos endovenosos. Algunos días después de iniciar el tratamiento, presenta aparición de lesiones generalizadas, que abarcan el 20% de la superficie corporal, consistentes en eritema, pápulas, vesículas y bulas dolorosas, con compromiso de la mucosa oral y ojo rojo, sin signo de Nikolsky. El diagnóstico más probable es:

a. Reacción anafiláctica
b. Eritema multiforme menor
c. Síndrome de piel escaldada
d. Síndrome de Steven Johnson
e. Necrosis epidermotóxica

Respuesta correcta: d. Síndrome de Steven Johnson

Explicación: En un SSJ (síndrome de Steven Johnson clásico): pápulas y vesículas, con afectación de las mucosas y conjuntivas y sin signo de Nikolsky (si estuviera, sería una necrosis epidermolítica tóxica o NET). El SSJ suele afectar entre el 10% y 30% de la superficie cutánea, mientras que la NET suele afectar más del 30%. Sin embargo, actualmente ambas se consideran una misma enfermedad, solo que con un grado distinto de severidad. Su tratamiento suele ser inmunomoduladores (ciclosporina) más corticoides sistémicos (prednisona; metilprednisolona si severo) e inmunoglobulina en los casos severos (aunque no tiene tanta evidencia). Eso sí, lo más importante es retirar el fármaco y cuidar las lesiones. - El eritema multiforme menor (EMM) tiene lesiones en tiro al blanco. - La reacción anafiláctica tiene angioedema o urticaria (habones y ronchas), más hipotensión que no responde a suero fisiológico.

Fuente: Dermatología, cuestionario 4.2, P16

97. Un paciente de 18 años presenta aparición de placas eritematosas, en tiro al blanco, ubicadas en el tronco y extremidades, de entre 1 y 4 cm de diámetro, luego de haber recibido un tratamiento con AINEs por una faringitis aguda. El diagnóstico más probable es:

a. Necrosis epidermotóxica
b. Síndrome de Steven Johnson

c. Mononucleosis infecciosa
d. Síndrome de Sweet
e. Eritema multiforme menor

Respuesta correcta: e. Eritema multiforme menor

Explicación: Las lesiones en target o tiro al blanco son características del eritema multiforme menor (EMM). Suele ser causado por infección por virus herpes simplex (VHS) y, en segundo lugar, por fármacos. Su diagnóstico es clínico (solo se biopsia en casos atípicos) y su tratamiento suele ser la simple observación, retirando la causa de base (ej. retirar el fármaco). En los casos causados por VHS se recomienda usar antivirales, pero por el VHS en sí, ya que no cambia mayormente el curso del EMM. - La necrosis epidermotóxica tiene ampollas y signo de Nikolsly (es muy grave). - El síndrome de Steven Johnson puede tener lesiones en tiro al blanco, pero afecta mucosas y conjuntivas y tiene vesículas y bulas además. - La mononucleosis puede tener exantema (30% de los casos, que sube a 90% si usa amoxicilina o ampicilina), pero le falta la odinofagia, fiebre y adenopatías del síndrome mononucleósico.

Fuente: Dermatología, cuestionario 4.3, P2

98. Un paciente de 19 años inicia tratamiento antibiótico, por una amigdalitis. Es traído dos días después por su madre, ya que presenta múltiples lesiones en "tiro al blanco" en el tronco y las extremidades. El diagnóstico más probable es:

a. Escarlatina
b. Erisipela
c. Mononucleosis
d. Eritema multiforme menor
e. Alergia a la penicilina

Respuesta correcta: d. Eritema multiforme menor

Explicación: Las lesiones en diana o en tiro al blanco son características del eritema multiforme menor (EMM). En este caso es causado por una reacción a fármacos. El tratamiento más importante es simplemente retirar el fármaco que lo causa. Sin embargo, se debe recordar que la causa más frecuente del EMM es la infección por virus herpes simplex, que se trata con aciclovir, aunque no cambie mayormente el curso del EMM en sí. - La escarlatina es un exantema papular en piel de gallina, que respeta el triángulo de Filatov. - La mononucleosis sí puede producir un exantema, en relación a la administración de aminopenicilinas, pero es de tipo morbiliforme (maculo-papular eritematoso), sin lesiones en tiro al blanco.

Fuente: Dermatología, cuestionario 4.4, P2

99. Paciente de 43 años, con antecedente de sífilis tratada hace 1 año, consulta por aparición de lesiones en manos y en algunas zonas del tronco de una semana de evolución, asociado a prurito y sensación febril. Refiere haber tomado AINEs y paracetamol hace una semana por lesión deportiva. Al examen físico se observa las siguientes lesiones: El diagnóstico más probable en este caso es:

a. Eritema multiforme menor
b. Sífilis secundaria
c. Molusco contagioso
d. Pónfolix
e. Prúrigo insectario

Respuesta correcta: a. Eritema multiforme menor

Explicación: Se ven lesiones en tiro al blanco, por lo que es un eritema multiforme menor. Está difícil, porque el cuadro clínico es inespecífico. La sífilis también puede tener placas similares, pero sin la imagen en tiro al blanco. El molusco contagioso tiene nódulos, no placas, con una depresión al medio. El pónfolix tiene vesículas tensas y pruriginosas en los dedos, manos y pies.

Fuente: Dermatología, cuestionario 4.5, P8

100. Un paciente de 10 años es hospitalizado por una celulitis, recibiendo tratamiento antibiótico endovenoso. Evoluciona al día siguiente con fiebre alta, odinofagia y aparición de vesículas y luego bulas en el tronco, extremidades y la cara, que respetan el cuero cabelludo. También aparecen ampollas en la boca, las que son muy dolorosas y dificultan la ingesta. Afecta cerca de un 15% de la superficie cutánea. El diagnóstico más probable es:



a. Síndrome de Steven Johnson
b. Necrosis epidermotóxica
c. Epidermolisis bulosa
d. Síndrome de piel escaldada
e. Ectima gangrenoso

Respuesta correcta: a. Síndrome de Steven Johnson

Explicación: Es un SSJ clásico. Es potencialmente grave, por lo que se debe hospitalizar, suspender el fármaco, manejar las heridas y administrar ciclosporina más corticoides. Si se agrava, se puede intentar agregar inmunoglobulina endovenosa.

Fuente: Dermatología, cuestionario 4.6, P1

Urticaria (3)

101. La lesión elemental de la urticaria es:

a. Roncha
b. Pápula
c. Mácula
d. Nódulo
e. Vesícula

Respuesta correcta: a. Roncha

Explicación: La urticaria se presenta como ronchas o pseudopápulas, que cuando son muy grandes evolucionan a habones y en casos más graves, también puede haber angioedema y shock anafiláctico.

Fuente: Dermatología, cuestionario 4.1, P18

102. Una paciente presenta, de manera recurrente, aparición de pseudopápulas muy pruriginosas en distintas zonas del cuerpo. Al examen se constata dermatografismo. El diagnóstico más probable es:

a. Dermatitis de contacto alérgica
b. Dermatitis atópica
c. Liquen plano
d. Urticaria
e. Escabiosis

Respuesta correcta: d. Urticaria

Explicación: Las pseudopápulas o ronchas son las lesiones elementales de la urticaria. El dermatografismo también es frecuente en la urticaria, aunque se ve en otras patologías, como el lupus y el hipertiroidismo. El tratamiento suele ser con antihistamínicos orales (ej. cetirizina, fexofenadina o incluso loratadina), idealmente de los no sedantes. Los corticoides no se indican, a menos que haya angioedema importante o que no responda a los antihistamínicos. Las demás también pueden ser pruriginosas, pero tienen pápulas y no pseudopápulas.

Fuente: Dermatología, cuestionario 4.3, P11

103. Un paciente presenta aparición de ronchas generalizadas, que desaparecen espontáneamente, pero recidivan con frecuencia. Las lesiones son muy pruriginosas y aumentan al rascarse. Al examen físico destaca dermatografismo. Se solicita TSH, hemograma y perfil bioquímico, que resultan normales. El tratamiento de elección para este paciente es:

a. Antihistamínicos orales
b. Corticoides orales
c. Corticoides tópicas
d. Levotiroxina oral
e. Crema humectante

Respuesta correcta: a. Antihistamínicos orales

Explicación: Tiene una urticaria crónica clásica (ronchas recidivantes y dermatografismo). Se trata con antihistamínicos orales, más evitar los agentes desencadenantes (ej. alérgenos, perfumes, etc.).

Fuente: Dermatología, cuestionario 4.5, P17

Manifestaciones cutáneas de enfermedades sistémicas (6)

104. Una paciente consulta por aparición recurrente de placas eritematosas, en las manos, el tronco y la cabeza, indoloras, de 1-2 cm de diámetro, que aumentan al exponerse al sol y que al desaparecer dejan cicatrices levemente deprimidas y áreas de alopecia permanente en el cuero cabelludo. El diagnóstico más probable es:

a. Tiña
b. Lupus discoide
c. Síndrome de Sweet
d. Dermatitis seborreica
e. Psoriasis

Respuesta correcta: b. Lupus discoide

Explicación: Es un lupus discoide clásico: placas eritematosas que dejan cicatriz, en zonas fotoexpuestas. Dejan cicatriz, por afectar la dermis, por tanto, cuando se afecta el cuero cabelludo, puede dejar zonas de alopecia cicatricial permanente. Si bien se suele dar de manera aislada, también se puede dar en contexto de un lupus eritematoso sistémico (LES) y, de hecho, es un criterio de LES. - El síndrome de Sweet es una reacción cutánea que se da en contexto de una leucemia mieloide aguda, o como reacción a fármacos o a algunas infecciones y se caracteriza por fiebre, neutrofilia y placas eritematosas dolorosas (su otro nombre es “erupción neutrofílica febril").

Fuente: Dermatología, cuestionario 4.1, P4

105. Una paciente de 25 años presenta fiebre intermitente, asociado a eritema y lesiones papulares en el dorso nasal y ambas mejillas, respetando el surco nasogeniano. El diagnóstico más probable es:

a. Dermatomiositis
b. Rosácea
c. Acné
d. Lupus sistémico
e. Lupus cutáneo subagudo

Respuesta correcta: d. Lupus sistémico

Explicación: Es un lupus eritematoso sistémico clásico, con la “mariposa lúpica” descrita.

Fuente: Dermatología, cuestionario 4.2, P7

106. Una paciente de 23 años presenta eritema de color violeta en los párpados superiores. El diagnóstico más probable es:

a. Rosácea
b. Lupus discoide
c. Lupus sistémico
d. Dermatomiositis
e. Esclerodermia

Respuesta correcta: d. Dermatomiositis

Explicación: La dermatomiositis se caracteriza por 3 afectaciones cutáneas: 1. Rash heliotropo (el de este caso), 2. Rash de Gottron (afectación de nudillos) y 3. Rash en manto (afectación de espalda y hombros). La rosácea sí puede tener afectación ocular, pero es más una blefaritis: eritema y descamación de los párpados, con especial afectación del borde cercano a las pestañas.

Fuente: Dermatología, cuestionario 4.4, P10

107. Un paciente de 23 años, sin antecedentes, consulta por disminución de fuerza de extremidades asociadas a aparición de lesiones en sus manos. Al examen físico se aprecia lo siguiente: El diagnóstico más probable en este caso es:



a. Lupus
b. Esclerodermia
c. Urticaria
d. Sífilis
e. Dermatomiositis

Respuesta correcta: e. Dermatomiositis

Explicación: Se ve el eritema sobre las articulaciones metacarpofalángicas e interfalángicas, lo que se conoce como rash de Gottron, que es una manifestación clásica de la dermatomiositis.

Fuente: Dermatología, cuestionario 4.5, P13

108. Un niño de 6 años presenta aparición de lesiones cutáneas en las extremidades inferiores, consistentes en pápulas rojas, que no blanquean con la compresión. Las lesiones no duelen y el niño está en buenas condiciones generales. Al examen físico se constata lo siguiente: El diagnóstico más probable es:

a. Púrpura de Schönlein Henoch
b. Síndrome de Steven Johnson
c. Tiña corporis
d. Síndrome de Kawasaki
e. Sarampión

Respuesta correcta: a. Púrpura de Schönlein Henoch

Explicación: Es una púrpura de Schönlein Henoch clásica.

Fuente: Dermatología, cuestionario 4.6, P16

109. La manifestación cutánea más frecuente de la espondilitis anquilosante y otras pelviespondiloartropatías es:

a. Sequedad de piel
b. Dermatomiositis
c. Eritema nodoso
d. Dermatitis herpetiforme
e. Esclerodermia

Respuesta correcta: c. Eritema nodoso

Explicación: El eritema nodoso y luego el pioderma gangrenoso son las patologías cutáneas más frecuentes asociadas a las pelviespondilopatías y también a las enfermedades inflamatorias intestinales. La sequedad de la piel es sugerente de dermatitis atópica. La dermatomiositis es sugerente de cáncer, ya que es un síndrome paraneoplásico. La dermatitis herpetiforme es sugerente de de enfermedad celíaca. La esclerodermia suele ser primaria y no secundaria a otras enfermedades.

Fuente: Dermatología, cuestionario 4.6, P17

Lesiones vasculares y dermatología neonatal (7)

110. Un niño presenta una mácula congénita, eritematosa, de bordes definidos, que compromete la frente y la región periocular derecha. No tiene otros síntomas. El diagnóstico más probable es:

a. Nevus flammeus
b. Mancha salmón
c. Nevo de Ota
d. Erisipela
e. Celulitis

Respuesta correcta: a. Nevus flammeus

Explicación: Como está solo en un lado de la cara, es un nevus flammeus. La mancha salmón está en la línea media. El nevo de Ota es azul, pero sí está en la mitad de la cara. La erisipela sí tiene bordes nítidos, pero no es congénita. La celulitis tampoco es congénita y tiene bordes difusos.

Fuente: Dermatología, cuestionario 4.1, P8

111. Un niño presenta una lesión eritematosa congénita en el labio inferior, solevantada, de aspecto vascular, que crece lentamente, a la misma velocidad que el niño. El diagnóstico más probable es:

a. Hemangioma
b. Higroma quístico
c. Mancha salmón
d. Nevus flameus
e. Malformación vascular

Respuesta correcta: e. Malformación vascular

Explicación: Que crezca a la par con el niño es característico de una malformación vascular (además suelen estar presentes desde el nacimiento). Los hemangiomas, en cambio, suelen crecer muy rápido y luego tienden a involucionar. El higroma quístico es una masa cervical grande y congénita, sugerente de genopatías.

Fuente: Dermatología, cuestionario 4.2, P9

112. Un recién nacido presenta una pequeña lesión roja solevantada en la zona sacra. Un mes después, la lesión ha crecido bastante, alcanzando los 4 cm de diámetro. El diagnóstico más probable es:

a. Nevus flameus
b. Malformación vascular
c. Hemangioma
d. Mancha salmón
e. Granuloma piógeno

Respuesta correcta: c. Hemangioma

Explicación: Es un hemangioma clásico: nódulo rojo en lactante, que crece más rápido que el niño y luego tiende a involucionar. La ubicación sacra es clásica, además de la ubicación periocular, nasal y peribucal. Si está en la zona sacra, es obligatorio descartar una espina bífida oculta, con una ecografía lumbosacra. Si son múltiples, se debe descartar la presencia de hemangiomas hepáticos con una ecografía abdominal. El tratamiento suele ser precoz, con propanolol oral (tiene riesgo de hipoglicemias en lactantes, por lo que se debe evitar el ayuno) y, si está contraindicado (ej. SBO), se indican corticoides orales. Sin embargo, en caso de hemangiomas pequeños, no complicados, ni deformantes, se pueden observar o manejar con timolol tópico, a fin de evitar los efectos adversos del propanolol.

Fuente: Dermatología, cuestionario 4.3, P7

113. Un niño de 4 meses de edad presenta aumento de volumen eritematoso, en relación al labio superior, en la zona derecha. La madre refiere que la lesión apareció hace un mes, pero que ha crecido considerablemente, siendo de 1 cm de diámetro actualmente. La conducta más adecuada es:

a. Observar evolución
b. Iniciar corticoides orales
c. Iniciar corticoides tópicos
d. Iniciar propanolol oral
e. Resolver quirúrgicamente

Respuesta correcta: d. Iniciar propanolol oral

Explicación: Tiene un hemangioma infantil clásico (nódulo violáceo que crece más rápido que el niño). El tratamiento de elección actualmente es el propanolol oral, salvo que tenga alguna contraindicación (ej. SBOR) o que se trate de un hamangioma muy pequeño y en un sitio irrelevante (en este caso, puede ser deformante). Los corticoides orales tópicos son una alternativa, cuando el propanolol está contraindicado o genera muchos efectos adversos. La resolución quirúrgica se da como última línea cuando sangran o se complican y no responden al tratamiento farmacológico. Si hubiese sido una malformación (crece al mismo ritmo que el niño), se puede observar o tratar con láser, si es que afecta estéticamente.

Fuente: Dermatología, cuestionario 4.4, P6

114. Un recién nacido presenta una mácula eritematosa de 15 x 8 mm de diámetro, en la línea media de la frente. El diagnóstico más probable es:

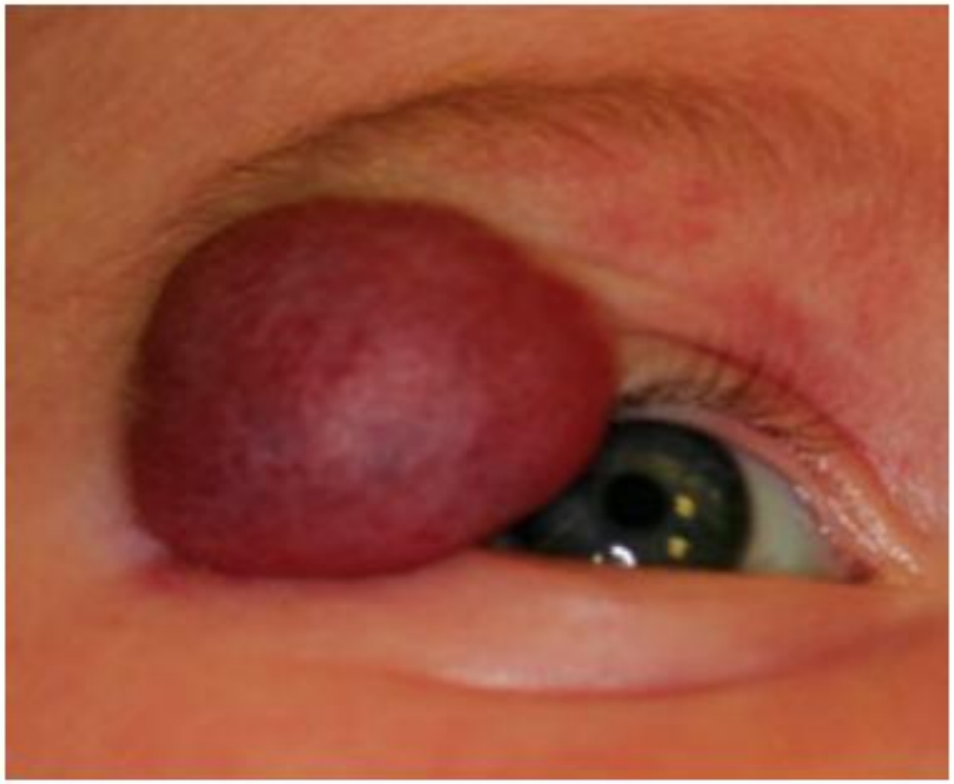
a. Nevus flammeus
b. Mancha salmón
c. Nevo de Ito
d. Hemangioma
e. Nevo de Ota

Respuesta correcta: b. Mancha salmón

Explicación: Como está en la línea media y es una mácula eritematosa, es una mancha salmón o "picotazo de la cigüeña". Tiene buen pronóstico y desaparece espontáneamente en algunos meses. El nevus flammeus es una mácula grande, ubicada en una mitad de la cara o en otra zona del cuerpo, que no pasa la línea media (o lo hace muy poco). El nevo de Ito es una mácula azulosa en el tórax u hombro (en el Hombr-Ito); el nevo de Ota es una máculo azulosa en la mitad de la cara (en la Car-Ota) El hemnagioma es un nódulo o tumor que crece rápido, de color rojo.

Fuente: Dermatología, cuestionario 4.4, P13

115. Lactante de 3 meses de edad, es traído por presentar aumento de volumen en parpado superior derecho, de color rojo, que apareció hace un mes y que ha ido en aumento, llegando incluso a ocluir parcialmente el ojo del menor, tal como se aprecia en la fotografía: La conducta más adecuada en este caso es:



a. Observar
b. Solicitar ecografía de superficie
c. Iniciar tratamiento con corticoides
d. Iniciar tratamiento con propanolol
e. Iniciar tratamiento con antibióticos

Respuesta correcta: d. Iniciar tratamiento con propanolol

Explicación: Tiene un hemangioma, que debe tratarse preferentemente con propanolol oral. Los corticoides orales o tópicos también sirven, pero el propanolol es de elección, tanto por su efectividad, como por los menores efectos adversos. Si bien hay casos que se prefieren observar, en este caso es un hemangioma grande, ubicado en un área en la que puede deformar o afectar la vista, por lo que, sin mucha duda, se debe tratar. Además, es adecuado el control con oftalmólogo en las lesiones perioculares.

Fuente: Dermatología, cuestionario 4.5, P9

116. Un recién nacido presenta una lesión roja en la cara y oreja derechaa, como se aprecia en la fotografía. El diagnóstico más probable es:

a. Hemangioma
b. Mancha salmón
c. Nevus flammeus
d. Malformación vascular
e. Nevo de Ota

Respuesta correcta: c. Nevus flammeus

Explicación: Es un nevus flammeus clásico, también llamado mancha de Oporto o mancha de vino tinto.

Fuente: Dermatología, cuestionario 4.6, P12

Trastornos de la pigmentación y del pelo (4)

117. La lesión elemental del léntigo solar es:

a. Placa
b. Pseudopápula
c. Pápula
d. Mácula
e. Nódulo

Respuesta correcta: d. Mácula

Explicación: Los léntigos solares son máculas (manchas) hiperpigmentadas.

Fuente: Dermatología, cuestionario 4.2, P17

118. Un paciente de 35 años presenta máculas blancas de algunos centímetros de diámetro, distribuidas en las zonas periocular, peribucal, los dedos y el pene. No tiene otros síntomas. El diagnóstico es:

a. Pitiriasis alba
b. Pitiriasis versicolor
c. Vitíligo
d. Nevo de Sutton
e. Leucoplaquias

Respuesta correcta: c. Vitíligo

Explicación: Es un vitíligo clásico: máculas acrómicas en cara, manos y pies, genitales, axilas y también pueden estar en otras zonas. Su tratamiento inicial suelen ser los corticoides tópicos de alta potencia (ej. clobetasol o betametasona por 2-3 meses, descansar un mes y retomarlo). Como alternativa, están los inhibidores de la calcineurina (tacrolimus, pimecrolimus) tópicos, en especial en zonas de piel que tienden a atrofiarse con los corticoides (ej. axilas y genitales). Existen múltiples otras terapias de manejo del especialista (ruxolitinib, fototerapia UVB, Psoraleno más UVA, etc.). Sin embargo, a modo de cultura general, los casos muy agresivos (ej. múltiples lesiones que progresan muy rápido), se recomienda de entrada usar corticoides orales más fototerapia para estabilizar la enfermedad. - La pitiriasis alba suele tener máculas hipopigmentadas, en la cara y hombros o brazos, con borde difuso y fina descamación. Se asocia a atopía. - La pitiriasis versicolor también tiene máculas hipopigmentadas, en el pecho y espalda. Se asocia al sudor, ya que se produce por un hongo. - El nevo de Sutton se caracteriza por tener una lesión

hiperpigmentada, rodeada por un halo hipopigmentado. Se asocia a vitíligo, pero si se vuelve muy irregular, se debe sospechar melanoma. - Las leucoplaquias están en las mucosas, no en la piel y se caracterizan por ser placas blanquecinas de lento crecimiento, que suponen una lesión premaligna.

Fuente: Dermatología, cuestionario 4.3, P4

119. Una paciente de 45 años consulta por caída de cabello. Al examen físico se aprecia una zona alopécica redonda, bien delimitada, de 5 cm de diámetro en la zona parietal izquierda. No presenta signos inflamatorios y el resto del cuero cabelludo es normal. El diagnóstico más probable es:



a. Lupus discoide
b. Lupus sistémico
c. Alopecia areata
d. Alopecia androgénica
e. Tiña capitis

Respuesta correcta: c. Alopecia areata

Explicación: Es una alopecia areata clásica.

Fuente: Dermatología, cuestionario 4.6, P5

120. El vitíligo se manifiesta como:

a. Pápulas
b. Máculas
c. Placas
d. Pseudopápulas
e. Vesículas

Respuesta correcta: b. Máculas

Explicación: Se caracteriza por máculas acrómicas o apigmentadas.

Fuente: Dermatología, cuestionario 4.6, P20

Oftalmología (50)

Ojo rojo: conjuntivitis, queratitis y uveítis (10)

1. Un paciente presenta dolor ocular izquierdo, que aumenta en situaciones de mucha luz, lo que le obliga a cerrar el ojo. Además, presenta epifora y ojo rojo. Al examen físico se aprecia ojo rojo periquerático, sin otras alteraciones. El diagnóstico más probable es:

a. Conjuntivitis bacteriana
b. Conjuntivitis viral
c. Queratitis aguda
d. Uveítis aguda
e. Glaucoma agudo

Respuesta correcta: c. Queratitis aguda

Explicación: Tiene una queratitis aguda clásica: ojo rojo profundo con fotofobia y epifora, sin alteración pupilar. Las conjuntivitis tienen ojo rojo superficial. La uveítis tiene miosis y el glaucoma agudo, midriasis (ambas tiene ojo rojo profundo).

Fuente: Oftalmología, cuestionario 3.1, P5

2. Un paciente de 18 años consulta por sensación de arenilla ocular, asociada a ojo rojo y secreción serosa en el ojo derecho. Al examen físico se constata ojo rojo superficial y se palpa una adenopatía preauricular. El diagnóstico más probable es:

a. Conjuntivitis viral
b. Conjuntivitis bacteriana
c. Conjuntivitis alérgica
d. Orzuelo
e. Dacriocistitis aguda

Respuesta correcta: a. Conjuntivitis viral

Explicación: Es una conjuntivitis viral clásica. Es conjuntivitis por el ojo rojo superficial y la sensación de arenilla ocular. La adenopatía y la secreción serosa orienta fuertemente a una causa viral (adenovirus es el más frecuente). También que se vuelva bilateral y que se asocie a fiebre, odinofagia o reacción tarsal folicular.

Fuente: Oftalmología, cuestionario 3.1, P12

3. Un paciente de 20 años, con antecedente de espondilitis anquilosante, presenta un cuadro de disminución de la agudeza visual derecha, asociada a dolor ocular ipsilateral. Al examen físico se aprecia ojo rojo profundo, asociado a pequeño hipopión y miosis del ojo derecho. El diagnóstico más probable es:

a. Uveítis aguda
b. Neuritis óptica
c. Epiescleritis
d. Endoftalmitis
e. Glaucoma agudo

Respuesta correcta: a. Uveítis aguda

Explicación: Es una uveítis aguda, tanto por el antecedente de espondilitis anquilosante (se asocia a las pelviespodilopatías y a las enfermedades inflamatorias intestinales), como por la clínica característica: ojo rojo profundo, miosis, hipopión, enoftalmo, efecto Tyndall, disminución de la agudeza visual y dolor. La neuritis óptica no produce ojo rojo, sino simplemente amaurosis y escape pupilar (defecto pupilar aferente). La epiescleritis se asocia a artritis reumatoide y produce dilatación de vasos sanguíneos en una zona de la esclera, que blanquean al aplicarles vasoconstrictores (a diferencia de la escleritis, que no blanquea). La endoftalmitis sí tiene ojo rojo e hipopión, pero suele ser masivo y se asocia a infecciones y cirugía, con apertura ocular. El glaucoma agudo tiene mucho dolor, inicio agudo, ojo rojo profundo y midriasis fija o arreactiva.

Fuente: Oftalmología, cuestionario 3.1, P13

4. Paciente de 19 años de edad, consulta por ojo rojo izquierdo, asociado a dolor, prurito y sensación de arenilla local de dos días de evolución. Al examen físico destaca reacción tarsal folicular y presencia de adenopatías delante y detrás de la oreja ipsilateral. El diagnóstico más probable es:

a. Conjuntivitis bacteriana
b. Conjuntivitis vírica
c. Conjuntivitis alérgica
d. Queratitis punctata
e. Queratitis por cuerpo extraño

Respuesta correcta: b. Conjuntivitis vírica

Explicación: Es una conjuntivitis viral clásica. Es conjuntivitis por el ojo rojo superficial y la sensación de arenilla ocular. La adenopatía y la reacción folicular orientan fuertemente a una causa viral (adenovirus es el más frecuente). También que se vuelva bilateral y que se asocie a fiebre, odinofagia y secreción serosa. La conjuntivitis alérgica tiene reacción tarsal papilar.

Fuente: Oftalmología, cuestionario 3.2, P3

5. Paciente de 20 años, sin antecedentes, consulta por ojo rojo superficial de 2 días de evolución, asociado a lesión en parpado superior derecho. Al examen físico se aprecia lesión eritematosa en zona media palpebral superior, doloroso a la palpación. El tratamiento más adecuado para esta patología es:

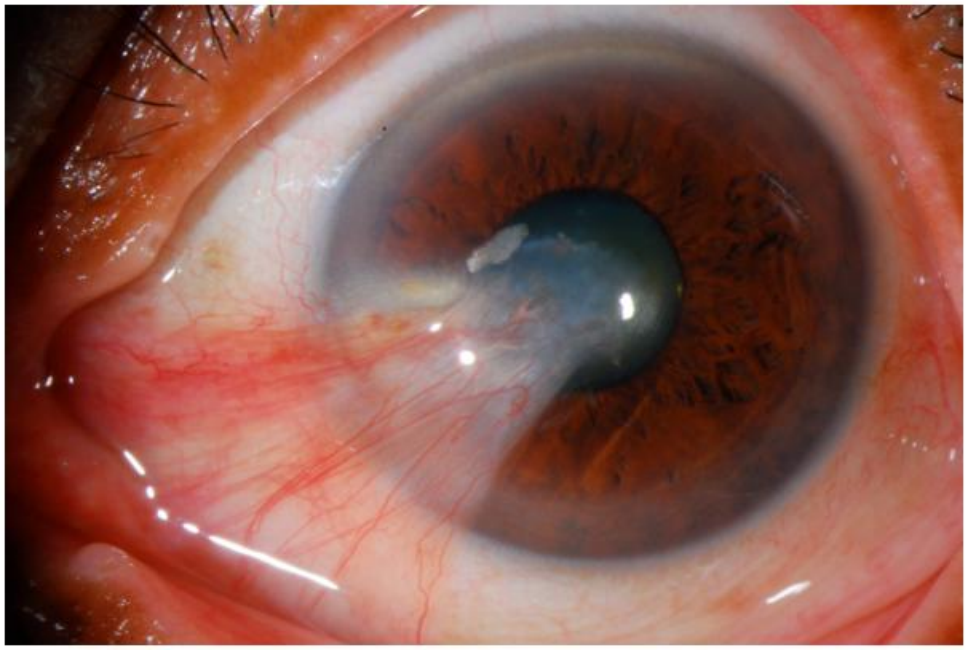
a. Colirios antibióticos
b. Antibióticos orales
c. Quirúrgico
d. Masajes suaves y aseo ocular
e. Corticoides orales

Respuesta correcta: d. Masajes suaves y aseo ocular

Explicación: Se describe un chalazión o, según la RAE, chalación, que se trata con masajes con calor húmedo, al igual que el orzuelo. Aunque muchas veces son indistinguibles, orzuelo y chalazión se pueden diferenciar en que 1. el chalazión demora algunos días en aparecer mientras que el orzuelo suele hacerlo en horas; 2. el orzuelo suele estar ubicado cerca del borde de las pestañas (se obstruye un folículo piloso), mientras que el chalazión está unos milímetros más alejados (se obstruye una glándula de Meibomio), aunque muchas veces el edema impide diferenciarlos y 3. el chalazión suele desaparecer en uno a dos meses, mientras que el orzuelo lo hace en una a dos semanas. Después de ese tiempo, se suelen derivar.

Fuente: Oftalmología, cuestionario 3.2, P9

6. Paciente de 68 años, con antecedente de diabetes mellitus 2 en tratamiento con hipoglicemiantes orales, consulta por ojo rojo asociado a sensación de arenilla ocular. Al examen físico se observa lo siguiente (fuente: Wikipedia): El diagnóstico es:



a. Glaucoma
b. Epiescleritis
c. Pterigion
d. Pinguécula
e. Queratitis

Respuesta correcta: c. Pterigion

Explicación: En la foto se ve un pterigion clásico: tumoración de la conjuntiva bulbar, que invade la córnea. En este caso, está en condiciones de ser removido quirúrgicamente, advirtiendo al paciente que tiene riesgo de recurrencia y que debe usar gafas de sol con ala ancha y sombrero, para evitar la exposición solar.

Fuente: Oftalmología, cuestionario 3.2, P10

7. Un paciente de 25 años, sin antecedentes, consulta por cuadro de dolor ocular de un día de evolución, asociado ojo rojo profundo y epifora. Al examen físico ocular se realiza tinción con fluoresceína que muestra patrón corneal dendrítico. El fármaco de elección para el manejo de este paciente es:

a. Dexametasona
b. Gentamicina
c. Ciprofloxacino
d. Ibuprofeno
e. Aciclovir

Respuesta correcta: e. Aciclovir

Explicación: Las úlceras dendríticas son propias de la queratitis herpética, que se trata con aciclovir tópico, más aciclovir oral. También se puede usar el valaciclovir.

Fuente: Oftalmología, cuestionario 3.2, P12

8. Paciente de 34 años, con antecedente de psoriasis en tratamiento, consulta por cuadro de 3 días de ojo rojo profundo izquierdo, asociado a dolor ocular y disminución de la agudeza visual. Al examen físico se aprecia lo siguiente: El diagnóstico más probable es:

a. Queratitis aguda
b. Glaucoma agudo
c. Uveítis aguda
d. Endoftalmitis
e. Escleritis

Respuesta correcta: c. Uveítis aguda

Explicación: Es una uveítis aguda, tanto por el antecedente de psoriasis (se asocia a las pelviespodilopatías y a las enfermedades inflamatorias intestinales), como por la clínica característica: ojo rojo profundo, miosis, hipopión, enoftalmo, efecto Tyndall, disminución de la agudeza visual y dolor. En la foto se ve el ojo rojo profundo y el hipopión. Se trata con corticoides tópicos, más el tratamiento de la causa de base. - La queratitis aguda sí tiene ojo rojo profundo, pero no tiene hipopión. Además, tiene epifora, blefarospasmo y fotofobia. - El glaucoma agudo tiene mucho dolor, inicio agudo, ojo rojo profundo y midriasis fija o arreactiva. - La endoftalmitis sí tiene ojo rojo e hipopión, pero suele ser masivo y se asocia a infecciones y cirugías con apertura ocular (ej. cirugía de cataratas). - La escleritis se asocia a artritis reumatoide y produce dilatación de vasos sanguíneos en una zona de la esclera, que no blanquean con los vasoconstrictores y que se asocian a dolor y eventualmente evolucionan a adelgazamiento de la esclera y herniación vítrea (a diferencia de la epiescleritis, que sí blanquea, no duele, es menos roja y suele ser autolimitada).

Fuente: Oftalmología, cuestionario 3.2, P15

9. Un hombre de 30 años consulta por ojo rojo izquierdo, asociado a dolor y disminución marcada de la agudeza visual. Al examen físico se aprecia ojo rojo profundo, con miosis y algún grado de enoftalmo. El diagnóstico más probable es:

a. Glaucoma de ángulo estrecho
b. Glaucoma de ángulo abierto
c. Queratitis aguda
d. Parálisis facial
e. Uveítis aguda

Respuesta correcta: e. Uveítis aguda

Explicación: Es una uveítis clásica: ojo rojo profundo, disminución de la AV, miosis y enoftalmo. Además, puede tener hipopión y efecto Tyndall. - El glaucoma agudo o de ángulo estrecho tiene ojo rojo profundo, con midriasis arrefléctica, más mucho dolor y disminución de la AV. - El glaucoma crónico o de ángulo abierto produce afectación del campo visual, con escotomas periféricos, que evolucionan a una visión tubular. - La queratitis aguda produce ojo rojo profundo y fotofobia, sin afectación pupilar. - La parálisis facial, a nivel ocular, impide que se cierre correctamente el párpado, lo que puede producir una queratitis punctata.

Fuente: Oftalmología, cuestionario 3.3, P1

10. Un paciente presenta sensación de arenilla ocular bilateral y secreción serosa, asociado a ojo rojo superficial, con reacción palpebral folicular. El diagnóstico más probable es:

a. Conjuntivitis viral
b. Conjuntivitis alérgica
c. Conjuntivitis bacteriana
d. Cuerpo extraño palpebral
e. Queratitis punctata

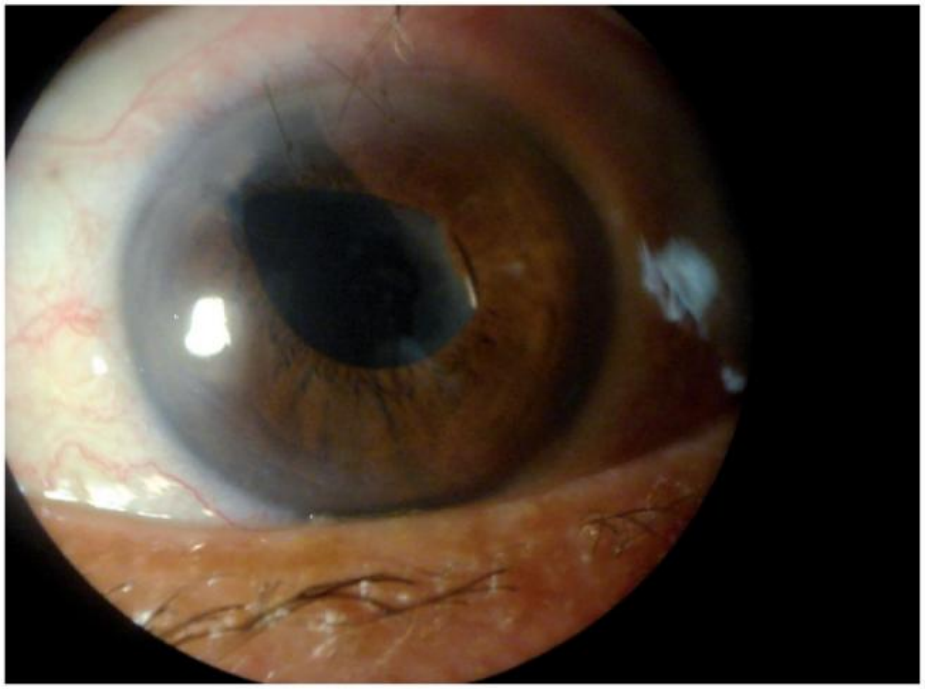
Respuesta correcta: a. Conjuntivitis viral

Explicación: Es una conjuntivitis viral clásica. La conjuntivitis alérgica tiene reacción tarsal folicular. La bacteriana no tiene reacción palpebral, sino abundante secreción purulenta y legañas. La queratitis punctata (por ojo seco) tiene clínica de queratitis: ojo rojo profundo, fotofobia, etc. Generalidades fracturas

Fuente: Oftalmología, cuestionario 3.3, P10

Trauma ocular y urgencias oftalmológicas (9)

11. Un paciente se mete en una pelea, resultando con un puñetazo en el ojo izquierdo. Al examen físico se aprecia los siguiente: La conducta más adecuada es:



a. Indicar analgésicos orales y observar evolución
b. Realizar aseo con suero fisiológico abundante e indicar antibióticos tópicos
c. Administrar antibióticos endovenosos y derivar de manera urgente a unidad de trauma ocular
d. Aplicar frío local y realizar sello ocular, con ungüento antibiótico
e. Realizar eversión tarsal y tinción con fluoresceína

Respuesta correcta: c. Administrar antibióticos endovenosos y derivar de manera urgente a unidad de trauma ocular

Explicación: Es un trauma ocular severo, ya que tiene discoria (deformación de la pupila), por lo que se sospecha un estallido ocular y se debe derivar urgentemente a la unidad de trauma ocular más cercana. Como médico general, no se debe tocar el ojo, ni aplicarle nada, pero sí se debe instalar una vía venosa y administrar analgésicos y antibióticos endovenosos (ejemplo, vancomicina más ceftazidima; vancomicina cubre Gram positivos, incluyendo el SAMR y la ceftazidima cubre Gram negativos, incluyendo Pseudomona).

Fuente: Oftalmología, cuestionario 3.1, P2

12. Un paciente estaba destapando una cañería con soda cáustica y al echar agua caliente, empezó a burbujear, salpicándole algunas gotas en los ojos. Evoluciona con intenso dolor y eritema ocular. Usted lo evalúa 20 minutos después en un servicio de urgencia, que no cuenta con especialistas. La conducta más adecuada es:

a. Derivar de inmediato a la unidad de urgencia oftalmológicas
b. Administrar propacaína tópica y realizar remoción del químico con un cotonito (hisopo) húmedo
c. Lavar con abundante suero fisiológico, a chorro, por 20 a 30 minutos y luego aplicar ungüento antibiótico y derivar
d. Administrar antibióticos endovenosos y analgésicos, sin tocar el ojo y derivar urgentemente a un centro de mayor complejidad, que cuente con oftalmólogo
e. Lavar con abundante agua por 30 minutos y enviar a domicilio, sin necesidad de mayor control

Respuesta correcta: c. Lavar con abundante suero fisiológico, a chorro, por 20 a 30 minutos y luego aplicar ungüento antibiótico y derivar

Explicación: La causticación ocular es una urgencia no derivable, en que el médico general debe lavar con abundante agua o suero fisiológico, a chorro, por 20 a 30 minutos, preocupándose de lavar bien los fondos de saco. Luego de eso, se debe aplicar ungüento antibiótico y derivar. Es discutible si se puede o no poner un parche ocular, dado que podrían generarse sinequias óculo-palpebrales, por lo que la mayoría recomienda no hacerlo. La opción D corresponde al manejo de una penetrante ocular o estallido ocular, la que no se debe confundir con la causticación ocular.

Fuente: Oftalmología, cuestionario 3.1, P11

13. Un paciente recibe un pelotazo en el ojo derecho, evolucionando con algo de dolor y ojo rojo. Al examen físico se aprecia una hemorragia subconjuntival, que abarca la mitad nasal de dicho ojo. Su agudeza visual, oculomotilidad, reflejo corneal, reflejo fotomotor y fondo de ojo son normales. La conducta más adecuada es:

a. Realizar aseo ocular con abundante agua
b. Administrar antibióticos y analgésicos endovenosos y derivar a la unidad de trauma ocular más cercana
c. Administrar antibióticos tópicos y derivar a oftalmología de inmediato
d. Indicar sello ocular con ungüento antibiótico y reposo relativo por 5 días
e. Indicar paracetamol oral si hay dolor y controlar de manera ambulatoria

Respuesta correcta: e. Indicar paracetamol oral si hay dolor y controlar de manera ambulatoria

Explicación: Tiene una contusión ocular sin signos de alarma, ya que la hemorragia conjuntival es un hallazgo banal, sin mayor trascendencia. Por tanto, se debe observar y a lo más indicar paracetamol, en caso de dolor.

Fuente: Oftalmología, cuestionario 3.1, P15

14. Un paciente 42 años, jardinero, presenta entrada de una astilla en el ojo. Al día siguiente presenta fotofobia y blefarospasmo, asociado a epífora y ojo rojo profundo. El diagnóstico más probable es:

a. Erosión corneal
b. Conjuntivitis aguda
c. Queratitis punctata
d. Uveítis aguda
e. Glaucoma de ángulo estrecho

Respuesta correcta: a. Erosión corneal

Explicación: Tanto las queratitis agudas, como las erosiones coneales, como las úlceras corneales tienen la misma clínica: ojo rojo profundo, asociado a epifora, blefarospasmo y fotofobia. El antecedente de la astilla, hace pensar en un cuerpo extraño tarsal, que se producjo la erosión corneal, por lo que se debe evertir el párpado y teñir con fluoresceína.

Fuente: Oftalmología, cuestionario 3.1, P19

15. Una niña de 5 años, cursando una sinusitis aguda, presenta eritema periocular izquierdo. Al examen físico presenta oculomotilidad conservada, reflejos fotomotor, de acomodación y corneal presentes y agudeza visual 20/20 en ambos ojos. El tratamiento más adecuado es:

a. Sintomático
b. Ciprofloxacino
c. Cefuroximo
d. Penicilina
e. Clindamicina

Respuesta correcta: c. Cefuroximo

Explicación: Tiene una celulitis preorbitaria o preseptal. Es una complicación muy frecuente de las sinusitis bacterianas. Se diferencia de la orbitaria o postseptal, que esta última tiene propotosis, disminución de la agudeza visual, afectación de la oculomotilidad o quemosis. Se trata con amoxicilina-clavulánico o con cefuroximo, ya que cubren bien al neumococo y también al estafilococo áureo, que son las dos causas más frecuentes. Si hubiese tenido elementos de celulitis orbitaria, se debería haber pedido una TAC de órbitas y senos paranasales, más antibióticos endovenosos de amplio espectro (ej. vancomicina más ceftriaxona) y, si se absceda, se debe operar y algunos agregan metronidazol.

Fuente: Oftalmología, cuestionario 3.2, P4

16. Paciente de 30 años, boxeador amateur, consulta por golpe en ojo derecho, asociado a aumento de volumen en zona palpebral ipsilateral. Al examen físico destacan parpados edematosos, movimientos oculares normales, pupilas simétricas, pero con presencia de hifema. La conducta más adecuada en este caso es:

a. Indicar reposo y enviar a domicilio
b. Realizar sello ocular con ungüento antibiótico
c. Realizar lavado ocular con abundante agua por al menos 20 minutos

d. Indicar control ambulatorio con oftalmólogo.
e. Derivar a la unidad de trauma ocular más cercana

Respuesta correcta: e. Derivar a la unidad de trauma ocular más cercana

Explicación: La presencia de hifema (sangre en la cámara anterior del ojo), hace que sea un trauma ocular severo, por lo que se debe derivar de inmediato a la unidad de trauma ocular más cercana. Debe hacerse en reposo semisentado, para evitar que la sangre tiña al cristalino o a la córnea. Además, se recomienda monitorear frecuentemente la presión intraocular, ya que el hifema se puede complicar con un glaucoma agudo. La mayoría se reabsorbe espontáneamente en unas pocas semanas.

Fuente: Oftalmología, cuestionario 3.2, P7

17. Un paciente recibe un golpe en el ojo, mientras trabajaba, presentando gran dolor. Al examen físico se aprecia lo siguiente (fuente: https://www.opcionmedica.com.uy/): La conducta inicial más adecuada es:



a. Realizar compresión ocular y derivar de manera urgente al centro de trauma ocular más cercano
b. Realizar lavado ocular con abundante agua y derivar de manera urgente al centro de trauma ocular más cercano
c. Administrar antibióticos endovenosos y derivar de manera urgente al centro de trauma ocular más cercano
d. Aplicar antibióticos tópicos y derivar de manera urgente al centro de trauma ocular más cercano
e. Realizar eversión tarsal y retirar el cuerpo extraño

Respuesta correcta: c. Administrar antibióticos endovenosos y derivar de manera urgente al centro de trauma ocular más cercano

Explicación: Tiene una laceración ocular, es decir, un trauma ocular gravísimo. Se debe derivar de inmediato a la unidad de trauma ocular más cercana. Como médico general, no se debe tocar el ojo, ni aplicarle nada, pero sí se debe instalar una vía venosa y administrar analgésicos y antibióticos endovenosos (ej. vancomicina más ceftazidima).

Fuente: Oftalmología, cuestionario 3.2, P20

18. Un paciente de 36 años, obrero de la construcción sufre un golpe en el ojo derecho con una herramienta. Al examen presenta disminución de la agudeza visual y deformación de la pupila con dicho ojo. La conducta inicial más adecuada es:

a. Lavar con abundante suero fisiológico por al menos 20 minutos
b. Aplicar ungüento antibiótico y sello ocular
c. Realizar compresión ocular por 10 minutos
d. Realizar tinción con fluoresceína
e. Administrar analgésicos y antibióticos e.v. y derivar de inmediato a la unidad de trauma ocular

Respuesta correcta: e. Administrar analgésicos y antibióticos e.v. y derivar de inmediato a la unidad de trauma ocular

Explicación: Es un trauma ocular severo, ya que tiene discoria (deformación de la pupila), por lo que se sospecha un estallido ocular y se debe derivar urgentemente a la unidad de trauma ocular más cercana. Como médico general, no se debe tocar el ojo, ni aplicarle nada, pero sí se debe instalar una vía venosa y administrar analgésicos y antibióticos endovenosos (ej. vancomicina más cefepime).

Fuente: Oftalmología, cuestionario 3.3, P6

19. Un paciente es operado de una catarata izquierda. Dos días después presenta dolor ocular y pérdida de la visión de dicho ojo. Al examen se aprecia ojo rojo profundo, con quemosis importante e hipopión que abarca toda la cámara anterior. El diagnóstico es:

a. Uveítis aguda
b. Glaucoma agudo
c. Celulitis orbitaria
d. Desprendimiento de retina
e. Endoftalmitis aguda

Respuesta correcta: e. Endoftalmitis aguda

Explicación: Es una endoftalmitis clásica: ojo rojo profundo e hipopión masivo. Además, suele tener dolor, pérdida de la visión y quemosis (edema de la conjuntiva bulbar). En este caso es secundaria a la cirugía (que es la causa más frecuente). Debe tratarse con antibióticos intraoculares, por lo que se debe derivar de inmediato.

Fuente: Oftalmología, cuestionario 3.3, P7

Glaucoma (7)

20. Un niño de 5 meses de edad presenta epífora bilateral, asociada a opacidad de ambas córneas. El diagnóstico más probable es:

a. Retinoblastoma
b. Atresia del conducto nasolagrimal
c. Conjuntivitis por Chlamydia trachomatis
d. Queratitis herpética
e. Glaucoma congénito

Respuesta correcta: e. Glaucoma congénito

Explicación: Es un glaucoma congénito clásico: epifora, opacidad corneal, fotofobia y buftalmo o megalocórnea. Su diagnóstico es clínico, confirmado por un oftalmólogo experto. El tratamiento es

quirúrgico. - El retinolastoma, en cambio, tiene leucocoria, estrabismo y proptosis. - La atresia del conducto lagrimal solo tiene epifora, sin opacidad corneal. - La conjuntivitis por Chlamydia trachomatis es una conjuntivitis bacteriana con tendencia a cronificar, que puede evolucionar a leucomas y tracomas y se asocia a neumonía neonatal en los niños. Los tracomas, en adultos, también son una patología frecuente en países de escasos recursos. - La queratitis herpética tiene ojo rojo profundo, epifora, blefarospasmo y, lo más importante, una úlcera dendrítica.

Fuente: Oftalmología, cuestionario 3.1, P3

21. Un paciente de 65 años presenta un escotoma periférico en el campo visual derecho. Además, al fondo de ojo, se aprecia aumento del diámetro de la excavación papilar. El diagnóstico más probable es:

a. Retinopatía hipertensiva
b. Neuritis óptica
c. Tumor hipofisiario
d. Glaucoma de ángulo abierto
e. Glaucoma de ángulo estrecho

Respuesta correcta: d. Glaucoma de ángulo abierto

Explicación: Tiene un glaucoma crónico clásico, también llamado glaucoma de ángulo abierto (el agudo se llama de ángulo estrecho). Se caracteriza por afectación del campo visual, iniciando con escotomas periféricos y terminando con una visión tubular (recién ahí se empieza a afectar la agudeza visual). Además, es característico que aumente la excavación papilar (mayor a 0,3 del diámetro de la papila óptica), ya que el glaucoma es una neuropatía óptica, que va dañando el nervio óptico. Se diagnostica con la clínica, sirviendo de apoyo la tonometría (que muestra elevación marcada de la PIO) y la genioscopía (que muestra el cierre del ángulo iridocorneal). Se trata inicialmente con fármacos para bajar la presión intraocular, tales como gotas mióticas (pindolol, timolol, pilocarpina), acetazolamida oral y manitol endovenoso. El tratamiento definitivo suele ser la iridotomía láser.

Fuente: Oftalmología, cuestionario 3.1, P10

22. ¿Qué fármacos están contraindicados en el paciente con glaucoma crónico?

a. Betabloqueantes
b. Anticolinérgicos
c. AINEs
d. Diuréticos
e. IECAs

Respuesta correcta: b. Anticolinérgicos

Explicación: Están contraindicados los fármacos que aumentan la producción de humor acuoso, o que disminuyen su absorción. Lo más importantes, son los anticolinérgicos, como los antidepresivos tricíclicos.

Fuente: Oftalmología, cuestionario 3.1, P17

23. Lactante de 2 meses de edad, sin antecedentes de importancia, es traído por presentar epifora a repetición desde hace 3 días, sin otros síntomas. Al examen físico destaca opacidad corneal, sin otros hallazgos. El diagnóstico más probable es:

a. Retinoblastoma
b. Glaucoma congénito
c. Toxoplasmosis congénita

d. Atresia lagrimal
e. Tracomas por Chlamydia trachomatis

Respuesta correcta: b. Glaucoma congénito

Explicación: Es un glaucoma congénito clásico: epifora, opacidad corneal, fotofobia y buftalmo o megalocórnea. - El retinolastoma, en cambio, tiene leucocoria, estrabismo y proptosis. - La atresia del conducto lagrimal solo tiene epifora, sin opacidad corneal. - EL tracoma producen una conjuntivitis crónica, que si no se trata, evoluciona a cicatrización de la mucosa palpebral y finalmente evoluciona a opacidad corneal y ceguera. Es causada por Chlamydia trachomatis y se trata con antibióticos que cubran dicha bacteria (doxiciclina o azitromicina).

Fuente: Oftalmología, cuestionario 3.2, P6

24. Paciente de 70 años, con antecedente de hipertensión arterial y dislipidemia en tratamiento, es traído por presentar caídas frecuentes, resultando una de ellas con fractura de cadera operada. Al examen físico se observa en buenas condiciones, pero al realizar examen de campo visual se aprecia alterado. Se realiza campimetría que se muestra a continuación: El diagnóstico más probable es:

a. Lesión de la cintilla óptica
b. Lesión del quiasma óptico
c. Lesión del lóbulo occipital
d. Glaucoma crónico
e. Neuritis óptica

Respuesta correcta: d. Glaucoma crónico

Explicación: La campimetría muestra afectación del campo visual periférico, bilateral, mayor en las zonas inferiores. De las opciones, la única posible es el glaucoma crónico, que se caracteriza por afectación del campo visual periférico (imagen A), evolucionando a una visión tubular (imagen C). La afectación puede ser muy asimétrica, tanto entre ambos ojos, como dentro de las distintas zonas del campo visual de un ojo. Eso sí, la afectación más clásica es el escotoma de Bjerrum, que afecta el campo visual superior y lateral (imagen B) y no de la zona inferior, sin embargo, puede tener variadas morfologías. Fuente: https://edumind.com.mx/ - Tanto la lesión de la cintilla óptica, como del lóbulo occipital producen himianopsias homónimas contralaterales. - La lesión del quiasma, produce una hemianopsia bitemporal. - La neuritis óptica produce amaurosis.

Fuente: Oftalmología, cuestionario 3.2, P11

25. Un paciente consulta por dificultad para ver de algunos meses de evolución. La inspección ocular es normal, al igual que la oculomotilidad y los reflejos. Se realiza un test de Snellen, que muestra agudeza visual 15/20 en OI y 20/20 en OD, sin embargo, hay pérdida de la visión periférica en ambos ojos, mayor en el OI. El diagnóstico más probable es:

a. Glaucoma crónico
b. Degeneración macular relacionada con la edad
c. Catarata
d. Edema macular
e. Neuritis óptica

Respuesta correcta: a. Glaucoma crónico

Explicación: Tiene escotomas bilaterales, mayores en la zona periférica, bastante asimétricos. En otras palabras, tiene un glaucoma crónico. La DMRE, las cataratas y el edema macular no afectan el campo visual, sino la agudeza visual. La neuritis óptica tiene amaurosis.

Fuente: Oftalmología, cuestionario 3.3, P3

26. Un niño de 3 meses de edad presenta epifora crónica. Al examen se aprecian ojos de mayor tamaño de lo normal. El diagnóstico más probable es:

a. Atresia lagrimal
b. Catarata congénita
c. Retinoblastoma
d. Glaucoma congénito
e. Conjuntivistis neonatal por Chlamydia trachomatis

Respuesta correcta: d. Glaucoma congénito

Explicación: Es un glaucoma congénito clásico: epifora y buftalmo (ojos grandes). Además, suele presentar megalocórnea y opacidad corneal. Atresia lagrimal: solo epifora. Catarata: leucocoria. Retinoblastoma: leucocoria, estrabismo y proptosis.

Fuente: Oftalmología, cuestionario 3.3, P8

Catarata y vicios de refracción (5)

27. Un paciente de 73 años ha presentado una lenta disminución de la agudeza visual, sin otros síntomas. Actualmente tiene agudeza visual 0,2 en un ojo y 0,1 en el otro, por lo que le es muy difícil desarrollar sus actividades de la vida diaria. En el examen físico se constata pérdida del rojo pupilar bilateral, con oculomotilidad conservada y reflejos fotomotor y corneal normales. El diagnóstico más probable es:

a. Hemorragia vítrea
b. Cataratas
c. Glaucoma crónico
d. Degeneración macular relacionada con la edad (DMRE) e) Retinoblastoma

Respuesta correcta: b. Cataratas

Explicación: La pérdida lenta de la agudeza visual, en un adulto mayor, sugiere tanto cataratas, como degeneración macular relacionada con la edad (DMRE). Sin embargo, la afectación del rojo pupilar solo se ve en la catarata, ya que en la DMRE está normal. El glaucoma crónico no afecta la agudeza visual, sino el campo visual. Además, en el fondo de ojo tiene aumento del diámetro de la excavación papilar.

Fuente: Oftalmología, cuestionario 3.1, P8

28. Según el siguiente esquema: ¿ Cuál es el tratamiento del vicio de refracción descrito?

a. Lentes bifocales
b. Lentes biconvexos
c. Lentes bicóncavos
d. Lentes cilíndricos
e. Lentes intraoculares

Respuesta correcta: b. Lentes biconvexos

Explicación: Se aprecia que la imagen se enfoca por detrás de la retina, por tanto tiene una hipermetropía, la que se corrige con lentes biconvexos.

Fuente: Oftalmología, cuestionario 3.1, P9

29. Paciente de 9 años, de edad es derivado desde su colegio por falta de concentración en clases, al entrevistar a su madre y examinarlo destaca que tiene dificultad para ver objetos que están lejos pero no así los que están cerca. ¿Cuál es el tratamiento más adecuado en este vicio de refracción?:

a. Lentes cilíndricos
b. Lentes bifocales
c. Lentes biconvexos
d. Lentes bicóncavos
e. Lentes intraoculares

Respuesta correcta: d. Lentes bicóncavos

Explicación: Si bien falta información, la sospecha es una miopía, ya que tiene dificultades para ver de lejos ("corto de vista"). La miopía se trata con lentes bicóncavos. La hipermetropía, por el contrario, tiene dificultades para ver de cerca y se trata con lentes biconvexos.

Fuente: Oftalmología, cuestionario 3.2, P1

30. Paciente de 70 años de edad, con antecedente de HTA y dislipidemia en tratamiento, consulta por cuadro de meses de evolución de disminución de agudeza visual la cual empeora al mirar fuentes luminosas. Al examen físico destaca pérdida del rojo pupilar, presentando reflejos y oculomotilidad normales. El diagnóstico más probable en este caso es:

a. Glaucoma
b. Catarata
c. Presbicia
d. Retinoblastoma
e. Degeneración macular relacionada con la edad

Respuesta correcta: b. Catarata

Explicación: La pérdida lenta de la agudeza visual, en un adulto mayor, sugiere tanto cataratas, como degeneración macular relacionada con la edad (DMRE). Sin embargo, la afectación del rojo pupilar solo se ve en la catarata, ya que en la DMRE está normal. El encandilamiento, también sugiere más cataratas, aunque rara vez sí se puede ver en la DMRE. El glaucoma crónico no afecta la agudeza visual, sino el campo visual. Además, en el fondo de ojo tiene aumento del diámetro de la excavación papilar.

Fuente: Oftalmología, cuestionario 3.2, P2

31. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es compatible con el diagnóstico de astigmatismo?

a. Es menos frecuente que la hipermetropía
b. Se corrige con lentes biconvexos
c. Se corrige con lentes bicóncavos
d. La agudeza visual mejora al mirar por un agujero estenopeico
e. Tiene alto riesgo de glaucoma agudo

Respuesta correcta: d. La agudeza visual mejora al mirar por un agujero estenopeico

Explicación: Todos los vicios de refracción mejoran al mirar por un agujero estenopeico. El astigmatismo es el vicio de refracción más frecuente, seguido de la miopía y luego la hipermetropía. Se corrige con lentes cilíndricos. La hipermetropía, con lentes biconvexos. La miopía, con lentes bicóncavos. El glaucoma agudo se relaciona con la hipermetropía.

Fuente: Oftalmología, cuestionario 3.3, P9

Retina y pérdida visual (7)

32. Un paciente consulta por fotopsias y visión de puntos negros en la zona superior izquierda del campo visual. No refiere otros síntomas y la inspección no aporta mayor información. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

a. Derivar urgente a oftalmología
b. Solicitar una tonometría ocular
c. Solicitar una campimetría visual
d. Indicar parche ocular, con ungüento antibiótico y derivar a oftalmología, de manera ambulatoria
e. Observar evolución

Respuesta correcta: a. Derivar urgente a oftalmología

Explicación: Por la clínica de entopsias (puntos negros) y fotopsias (puntos luminosos), la sospecha es un desprendimiento de retina (de localización inferior derecha, dado que es contralateral al campo visual). La conducta es realizar un fondo de ojo urgente, más tratamiento láser o quirúrgico, lo antes posible.

Fuente: Oftalmología, cuestionario 3.1, P6

33. ¿Cuál de las siguientes alteraciones representa una mayor gravedad en la retinopatía diabética?

a. Exudados céreos retinales
b. Vasos de neoformación retinales
c. Microaneurismas retinales
d. Microhemorragias retinales
e. Microinfartos retinales

Respuesta correcta: b. Vasos de neoformación retinales

Explicación: Los vasos de neoformación, son parte de la retinopatía diabética proliferativa. Por tanto, son más graves que todo lo demás (que se ve en la no proliferativa). Lo único más grave son las hemorragias prerretinales y luego las hemorragias vítreas (que ya dejan ciego al paciente).

Fuente: Oftalmología, cuestionario 3.1, P7

34. Un paciente de 60 años, con antecedente de hipertensión arterial y diabetes, presenta pérdida súbita de la visión del ojo izquierdo, sin dolor ni otros síntomas. Es capaz de distinguir siluetas y de contar dedos, sin embargo, no puede leer ni distinguir las caras. El rojo pupilar está presente en ambos ojos. El diagnóstico más probable es:

a. Hemorragia vítrea
b. Neuritis óptica
c. Desprendimiento de retina
d. Trombosis de la vena central de la retina
e. Oclusión de la arteria central de la retina

Respuesta correcta: d. Trombosis de la vena central de la retina

Explicación: Es una TVCR (trombosis de la vena central de la retina) clásica: pérdida de la visión de un ojo, pero que puede ver algo. Se debe realizar un fondo de ojo urgente para confirmar. - La hemorragia vítrea pierde el rojo pupilar. - La neuritis óptica no se instala tan súbitamente y tiene defecto pupilar aferente. - El desprendimiento de retina tiene fotopsias y entopsias, seguidas de una “caída de telón”, más defecto

pupilar aferente. - La oclusión de la arteria central de la retina (OACR) tiene pérdida completa de la visión y no es capaza de ver las siluetas, ni contar dedos.

Fuente: Oftalmología, cuestionario 3.1, P16

35. Un paciente presenta una oclusión de la arteria central de la retina (OAC), ¿cuál es el examen o conjunto de exámenes más útil para identificar la etiología de dicha patología?

a. Recuento de plaquetas, TTPA y TP
b. Angiografía carotidea
c. Hemograma-VHS y biopsia de arteria temporal
d. Resonancia magnética de cerebro
e. Ecografía doppler de carótidas

Respuesta correcta: e. Ecografía doppler de carótidas

Explicación: La causa más frecuente de la OAC son las embolias arterio-arteriales, provenientes de la carótida. Por tanto, se estudia igual que un AVE embólico, con Eco-Doppler de carótidas, ecocardiograma y Holter de arritmias, siendo el Doppler carotídeo lo más importante.

Fuente: Oftalmología, cuestionario 3.1, P20

36. Paciente de 60 años, con antecedentes de diabetes mellitus insulino dependiente, insuficiencia renal crónica en hemodiálisis e hipertensión, presenta cuadro de fotopsias y entopsias de 2 días de evolución. Actualmente persisten los síntomas y se agrega disminución de la agudeza visual. Al examen físico se realiza fondo de ojo que muestra lo siguiente: El diagnóstico más probable es:

a. Retinopatía diabética proliferativa
b. Degeneración macular relacionada con la edad
c. Oclusión de la arteria central de la retina
d. Edema macular
e. Desprendimiento de retina

Respuesta correcta: e. Desprendimiento de retina

Explicación: La clínica (fotopsias y entopsias, seguidas de afectación de la visión) sugiere un desprendimiento de retina. El fondo de ojo (en que se ve) lo confirma. Se debe resolver quirúrgicamente.

Fuente: Oftalmología, cuestionario 3.2, P13

37. Un paciente de 69 años presenta pérdida completa de la visión del ojo izquierdo, de inicio súbito, que dura cerca de 15 minutos y luego se recupera por completo. La causa más probable de este cuadro es:

a. Embolia arterial
b. Trombosis venosa
c. Neuritis óptica
d. Glaucoma agudo
e. Desprendimiento de retina

Respuesta correcta: a. Embolia arterial

Explicación: Tiene una amaurosis fugax. Es considerada un accidente isquémico transitorio (TIA), el que habitualmente se produce por embolias arterio-arteriales, por lo que se debe estudiar con un eco-Doppler de carótidas. También, por ser adulto mayor, se debe descartar una arteritis de la temporal (AT), solicitando un hemograma y VHS (la AT tiene la VHS muy elevada).

Fuente: Oftalmología, cuestionario 3.2, P19

38. Un paciente sufre pérdida de la visión del ojo izquierdo, de inicio súbito hace un par de horas. Sólo reconoce siluetas y es capaz de contar dedos con dicho ojo. No presentó otros síntomas. El diagnóstico más probable es:

a. Glaucoma agudo
b. Embolia arterial retinal
c. Trombosis venosa retinal
d. Desprendimiento de retina
e. Coriorretinitis

Respuesta correcta: c. Trombosis venosa retinal

Explicación: Es una TVCR (trombosis de la vena central de la retina) clásica: pérdida de la visión de un ojo, pero que puede ver algo. El glaucoma agudo produce ojo rojo profundo con semimidriasis fija. La oclusión de la arteria central de la retina (OACR) tiene pérdida completa de la visión y no es capaza de ver las siluetas, ni contar dedos. El desprendimiento de retina tiene fotopsias y entopsias, seguidas de una "caída de telón", más defecto pupilar aferente. La corioretinitis produce disminución progresiva de la agudeza visual.

Fuente: Oftalmología, cuestionario 3.3, P4

Neuroftalmología (9)

39. Una lesión del III nervio craneal presentará todo lo siguiente, EXCEPTO:

a. Midriasis
b. Imposibilidad de mirar hacia arriba
c. Imposibilidad de mirar hacia abajo
d. Imposibilidad de mirar hacia medial
e. Imposibilidad de cerrar el ojo

Respuesta correcta: e. Imposibilidad de cerrar el ojo

Explicación: El III nervio craneal u oculomotor abre el ojo (su lesión produce ptosis). Además, mira hacia arriba, abajo y medial. Finalmente es el encargado de la miosis (su lesión produce midriasis). En cambio, el VII nervio craneal o facial es quien cierra el ojo.

Fuente: Oftalmología, cuestionario 3.1, P1

40. Un paciente de 20 años presenta anisocoria, con ligera midriasis a izquierda. Al examen físico se aprecia que ambas pupilas se contraen a iluminar cualquiera de los ojos, pero que la pupila izquierda siempre es de un tamaño mayor a la pupila derecha. El diagnóstico más probable es:

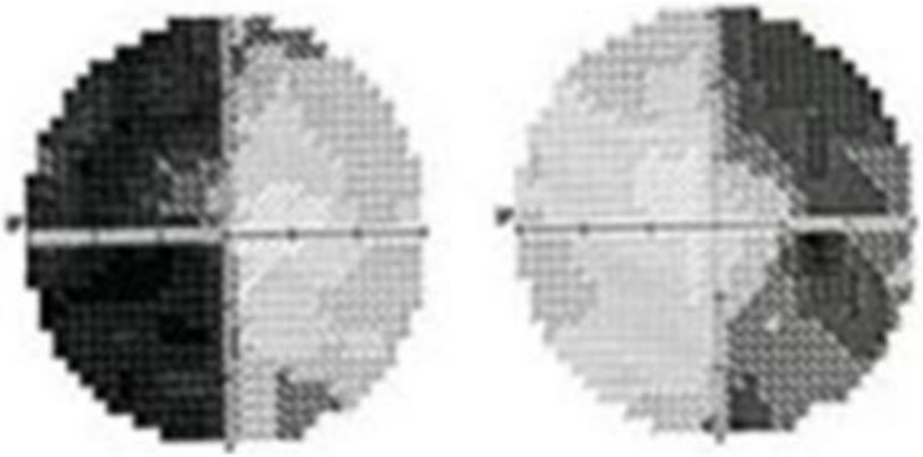
a. Pupila de Addie
b. Pupila de Argyll Robertson
c. Defecto pupilar aferente (pupila de Marcus Gunn)
d. Defecto pupilar eferente
e. Síndrome de Claude Bernard Horner

Respuesta correcta: a. Pupila de Addie

Explicación: Es una pupila de Addie clásica: anisocoria, pero fotorreactiva bilateral, con una pupila que habitualmente está más midriática que la otra. La pupila de Argyll Robertson (neurosífilis), en cambio, pierde el reflejo fotomotor, pero mantiene el de acomodación.

Fuente: Oftalmología, cuestionario 3.1, P4

41. Un paciente presenta la siguiente campimetría visual: El diagnóstico más probable es:



a. Glaucoma crónico
b. Glaucoma agudo
c. Tumor de hipófisis
d. Lesión de la cintilla óptica
e. Lesión del lóbulo occipital

Respuesta correcta: c. Tumor de hipófisis

Explicación: Tiene una hemianopsia bitemporal, por lo que se debe sospechar una lesión de quiasma óptico, cuya causa más frecuente es el tumor de hipófisis.

Fuente: Oftalmología, cuestionario 3.1, P14

42. Una paciente de 25 años presenta amaurosis derecha, que se instaló en el transcurso de algunas horas, asociado a escape pupilar, de un día de evolución, sin otros síntomas. El diagnóstico más probable es:

a. Neuritis óptica
b. Desprendimiento de retina
c. Trombosis de la vena central de la retina
d. Hemorragia vítrea
e. Oclusión de la arteria central de la retina

Respuesta correcta: a. Neuritis óptica

Explicación: Es una neuritis óptica clásica, tanto por instalarse de manera aguda, pero no súbita, como por el defecto pupilar aferente o escape pupilar. Se asocia a esclerosis múltiple (EM), por lo que se estudia no solo con resonancia magnética de nervio óptico, sino de cerebro y médula ósea, para descartar otros focos de desmielinización. Se trata con corticoides endovenosos y, luego, con drogas modificadoras de la EM en el caso de que sea por esta patología (Ej. Natalizumab, Ocrelizumab, Rituximab). Recordar que el fondo de ojo suele estar normal, salvo en casos de afectación anterior, en que se produce edema de papila.

Fuente: Oftalmología, cuestionario 3.1, P18

43. Un paciente de 70 años consulta por marcada disminución de la visión del ojo derecho, de un día de evolución, asociado a dolor ocular leve. Al examen físico se aprecia un defecto pupilar aferente y el fondo de ojo demuestra edema de papila. El diagnóstico más probable es:

a. Trombosis de la vena central de la retina
b. Oclusión de la arteria central de la retina
c. Hemorragia vítrea
d. Desprendimiento de retina
e. Neuritis óptica

Respuesta correcta: e. Neuritis óptica

Explicación: Tiene una neuritis óptica clásica: amaurosis con escape pupilar. Además, puede dolor levemente, en especial con los movimientos del ojo. - El edema de papila es propio de la neuritis óptica anterior, ya que la papila óptica es el punto de inicio del nervio óptico. - La TVCR tiene pérdida súbita de la visión de un ojo, pero mantiene algo de visión (ej. cuenta dedos). - La oclusión de la arteria central de la retina (OACR) tiene pérdida completa de la visión y no es capaza de ver las siluetas, ni contar dedos. La hemorragia vítrea pierde el rojo pupilar. - El desprendimiento de retina tiene fotopsias y entopsias, seguidas de una "caída de telón", más defecto pupilar aferente.

Fuente: Oftalmología, cuestionario 3.2, P8

44. Paciente diabético tipo 2, IR, con IRC, presenta desviación de ojo izquierdo a izquierda, asociada a midriasis ipsilateral desde hace 14 días. Además, presenta ptosis de dicho ojo. El diagnóstico más probable es:

a. Lesión del III nervio craneal
b. Lesión del IV nervio craneal
c. Lesión del VI nervio craneal
d. Lesión del fascículo longitudinal medial
e. Lesión del ganglio estrellado

Respuesta correcta: a. Lesión del III nervio craneal

Explicación: Es una parálisis del III nervio craneal clásica, cuya causa más frecuente es la diabetes, seguida por los traumatismos. El III nervio craneal u oculomotor abre el ojo (su lesión produce ptosis). Además, mira hacia arriba, abajo y medial, siendo el encargado de la miosis (su lesión produce midriasis). Finalmente, se produce un estrabismo divergente, ya que el VI nervio tracciona al ojo hacia lateral. - El IV nervio craneal mira hacia inferomedial. Su causa más frecuente es el traumatismo, seguido de la diabetes. - El VI nervio craneal mira hacia lateral. Su causa más frecuente es el traumatismo, seguido de la diabetes. - El FLM mira hacia medial en la mirada conjugada (su lesión impide mirar hacia medial y produce nistagmo). Se produce por lesiones de troncoencéfalo (AVE, esclerosis múltiple, tumores). - El ganglio estrellado lleva la vía simpática, por lo que su lesión produce un síndrome de Horner (miosis, ptosis, anhidrosis). La causa más frecuente es el cáncer de pulmón.

Fuente: Oftalmología, cuestionario 3.2, P16

45. Paciente de 35 años, con antecedente de VIH en tratamiento irregular, presenta abolición del reflejo fotomotor bilateral, pero con presencia de reflejo de acomodación que permanece normal. Sus pupilas son pequeñas y algo anisocóricas. El diagnóstico más probable es:

a. Coriorretinitis por citomegalovirus
b. Pupila de Addie

c. Neurosífilis
d. Neuritis óptica
e. Síndrome de Claude Bernard Horner

Respuesta correcta: c. Neurosífilis

Explicación: Tiene una pupila de Argyll Robertson: pérdida del reflejo fotomotor, con preservación del reflejo de acomodación. Su causa es la neurosífilis, que se estudio con VDRL o RPR más FTA-ABS o MHA-TP, a lo que, para el caso específico de la neurosífilis, se debe agregar el VDRL en líquido cefalorraquídeo. - La coriorretinitis por CMV tiene disminución de la agudeza visual bilateral, progresiva, por lo que se debe hacer un fondo de ojo para diagnosticarla y tratarlo con ganciclovir.

Fuente: Oftalmología, cuestionario 3.2, P17

46. Un paciente presenta imposibilidad de mirar hacia la derecha con el ojo izquierdo. El resto de los movimientos oculares están conservados. La lesión se encuentra en:

a. Músculo recto superior
b. Nervio abducente
c. Nervio oculomotor
d. Nervio troclear
e. Fascículo longitudinal medial

Respuesta correcta: e. Fascículo longitudinal medial

Explicación: No puede mirar hacia medial con un ojo. La mirada hacia medial se realiza mediante el III nervio craneal, pero es coordinada por el fascículo longitudinal medial (FLM), en la mirada conjugada. Como solo está afectada la mirada a medial y no hacia otros lados, la causa es una lesión del FLM. En cambio, el III nervio craneal además tendría imposibilidad de mirar hacia arriba y hacia abajo, más ptosis y midriasis.

Fuente: Oftalmología, cuestionario 3.2, P18

47. Un paciente diabético presenta diplopía de inicio súbito. Al examen físico presenta ptosis y midriasis derecha, con imposibilidad de mirar a medial, a arriba y abajo con el ojo derecho. El diagnóstico más probable es:

a. Lesión del fascículo longitudinal medial
b. Lesión del III nervio craneal
c. Lesión del IV nervio craneal
d. Lesión del VI nervio craneal
e. Síndrome de Horner

Respuesta correcta: b. Lesión del III nervio craneal

Explicación: Es una parálisis del III nervio craneal clásica.

Fuente: Oftalmología, cuestionario 3.3, P2

Oftalmología pediátrica (3)

48. Lactante de 3 meses de edad, sin antecedentes de importancia, es traído por presentar desviación ocular. Al examen físico se aprecia leve estrabismo del ojo izquierdo de carácter fluctuante. La conducta más adecuada es:

a. Realizar castigo ocular alternante

b. Indicar fortalecimiento de músculos oculomotores, utilizando prismas
c. Resolver quirúrgicamente
d. Realizar fondo de ojo
e. Observar evolución

Respuesta correcta: e. Observar evolución

Explicación: El estrabismo es una causa de derivación oftalmológica, en pediatría, ya que tiene riesgo de desarrollar ambliopía. Sin embargo, si el niño tiene menos de 6 meses y su estrabismo no es fijo, sino fluctuante, es posible mantener una conducta expectante, hasta los 6 meses, en que se debe derivar.

Fuente: Oftalmología, cuestionario 3.2, P5

49. Lactante de 4 meses, con antecedente de prematurez de 36 semanas, es traído por presentar estrabismo del ojo derecho, sin otros síntomas. Al examen físico se aprecia estrabismo fijo hacia temporal y pérdida del rojo pupilar. El diagnóstico más probable es:

a. Retinoblastoma
b. Catarata congénita
c. Estrabismo correctivo
d. Glaucoma crónico
e. Retinopatía del prematuro

Respuesta correcta: a. Retinoblastoma

Explicación: Es una pregunta difícil, pero se trata de un retinoblastoma. Su triada característica es leucocoria, estrabismo y proptosis, pero en este caso solo se ve el estrabismo y la pérdida del rojo pupilar, dado que se interpone el retinoblastoma por delante de la retina. - La catarata sí tiene leucocoria y pérdida del rojo pupilar, pero no tiene estrabismo. - El estrabismo correctivo no es fijo, sino fluctuante y no tiene afectación del rojo pupilar. - El glaucoma crónico tiene opacidad corneal, buftalmo y epifora. - La retinopatía del prematuro afecta a prematuros de menos de 32 semanas o menos de 1.500 gramos al nacer y puede tener leucocoria. Sin embargo, lo más importante es el riesgo de desprendimiento de retina, de no tratarse oportunamente. Por eso, en recién nacidos menores de 32 semanas o 1.500 gramos se debe seguir con fondos de ojos periódicos, hasta la completa vascularización normal de la retina y, si se desarrolla retinopatía, eventualmente se debe fotocoagular, para evitar la ceguera.

Fuente: Oftalmología, cuestionario 3.2, P14

50. Un niño de 7 meses de edad presenta alteración de la prueba de Hirschberg. La conducta más adecuada es:

a. Observar evolución
b. Realizar masajes oculares
c. Iniciar colirios antibióticos
d. Solicitar tonometría ocular
e. Derivar a oftalmología

Respuesta correcta: e. Derivar a oftalmología

Explicación: Tiene estrabismo, por lo que se debe derivar, para evitar que desarrolle ambliopía a futuro. Solo se puede mantener en observación el estrabismo fluctuante, en un menor de 6 meses, por ser frecuente y transitorio. También se derivan si existe alteración del cover test y en las endotropias de más 4 meses de edad.

Fuente: Oftalmología, cuestionario 3.3, P5

Otorrinolaringología (49)

Patología del oído (9)

1. Un niño de 4 años, sin antecedentes, es derivado desde su jardín por retraso en el lenguaje. No refiere otros síntomas. Al examen destacan tímpanos opacos sin otras alteraciones. Se realiza estudio con impedanciometría que muestra la siguiente curva: El diagnóstico más probable es:

a. Otitis media aguda
b. Otitis externa difusa
c. Otitis media crónica
d. Otitis media con efusión
e. Otitis media recurrente

Respuesta correcta: d. Otitis media con efusión

Explicación: Tiene una curva B (plana), por lo que se confirma el diagnóstico de OME, que es la causa más frecuente de hipoacusia en los niños y se caracteriza por tímpanos rosados y opacos. La otitis media aguda (OMA) también tiene una curva B, pero su clínica es completamente diferente (fiebre, otalgia e irritabilidad). La otitis externa (OE) no produce hipoacusia, sino otalgia y otorrea. La otitis media crónica (OMC) afecta a los adultos. Finalmente, OMA, OE y OMC tienen otoscopías diferentes.

Fuente: Otorrinolaringología, cuestionario 2.1, P8

2. Paciente de 59 años, con antecedente de otitis media aguda a repetición en la niñez, consulta por cuadro de meses de otorrea del oído derecho, la cual ha aumentado en los últimos días agregándose fiebre. Al examen físico se observa eritema en zona retroauricular derecha, sensible a la palpación, y a la otoscopía se observa perforación timpánica ipsilateral con presencia de secreción purulenta. El tratamiento de elección frente a este paciente es:

a. Antibióticos endovenosos
b. Corticoides endovenosos
c. Cirugía de urgencia
d. Antibióticos tópicos (gotas óticas)
e. Antiinflamatorios orales

Respuesta correcta: a. Antibióticos endovenosos

Explicación: Tiene una otitis media crónica (OMC) clásica (por la perforación y otorrea), complicada con una mastoiditis aguda (por la fiebre y eritema retroauricular). Si bien la OMC se trata con antibióticos tópicos, la mastoiditis obliga a hospitalizarlo y tratarlo con antibióticos endovenosos. Los antibióticos de la mastoiditis deben cubrir los microorganismos de la otitis media aguda (ej. ceftriaxona), pero, si proviene de una OMC, además, es fundamental cubrir pseudomona, por lo que quedará con cefepime o alguna otra formulación de amplio espectro, con cobertura de P. aureginosa.

Fuente: Otorrinolaringología, cuestionario 2.1, P9

3. Paciente de 62 años, con antecedente de diabetes mellitus tipo 2 sin tratamiento, consulta por otalgia izquierda y gran decaimiento. Al examen se ve febril (39°C), normotenso y taquicárdico (110 x'), además presenta eritema del pabellón auricular izquierdo y en la zona preauricular, asociada a otorrea purulenta. El tratamiento más adecuado en este caso es:

a. Administrar gentamicina tópica

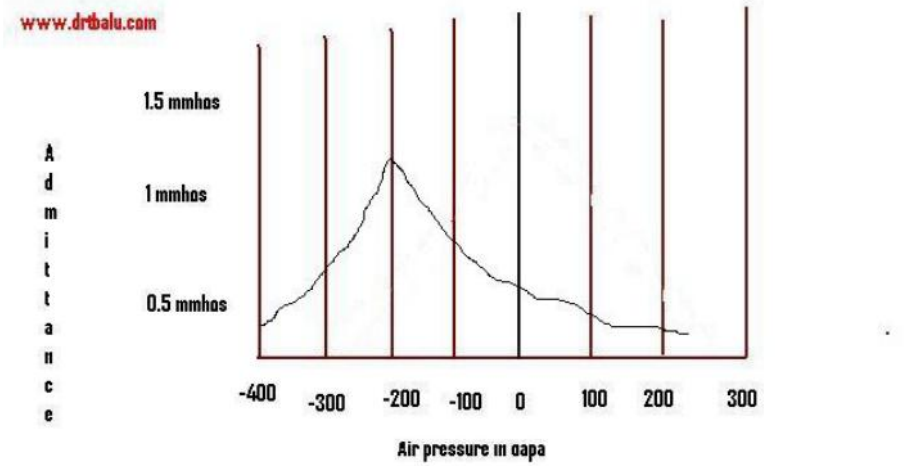
b. Administrar ciprofloxacino tópico asociado a amoxicilina oral
c. Administrar ceftazidima y amikacina ev
d. Administrar cefadroxilo y clindamicina ev
e. Realizar aseo quirúrgico en pabellón asociado a antisépticos tópicos

Respuesta correcta: c. Administrar ceftazidima y amikacina ev

Explicación: Tiene una otitis externa maligna (otorrea, otalgia y luego eritema de la oreja o la cara). Es una infección grave, causada por Pseudomona aureginosa, habitualmente en pacientes diabéticos o neutropénicos. Se trata con antibióticos endovenosos antipesudomona (ceftazidima, cefoperazona, cefepime o carbapenémicos, más tobramicina, amikacina o kanamicina).

Fuente: Otorrinolaringología, cuestionario 2.1, P12

4. Un paciente consulta por sensación de oído izquierdo tapado. No ha presentado vértigo ni otros síntomas. El examen físico es normal. Se solicita audiometría, que está pendiente y una impedanciometría, que se muestra a continuación: El diagnóstico más probable es:



a. Disfunción tubárica
b. Otitis media con efusión
c. Otesclerosis
d. Presbiacusia
e. Sano

Respuesta correcta: a. Disfunción tubárica

Explicación: Tiene una curva C (curva desplazada hacia los valores negativos), que es diagnóstica de disfunción tubárica. La OME tiene curvas B (plana) o Cs (baja y desplazada hacia las presiones negativas). La otoesclerosis tiene curca As (baja y con el vértice en el 0). La presbiacusia, como toda hipoacusia sensorioneural, tiene curvas A o normales (de altura normal, con el vértice en el cero), dado que no hay alteraciones en el tímpano u oído medio.

Fuente: Otorrinolaringología, cuestionario 2.2, P2

5. Un niño de dos años es traído por su madre, por otalgia, asociada a fiebre hasta 38,5 °C, de dos días de evolución. Se realiza otoscopia, que muestra tímpano izquierdo abombado, eritematoso, con una perforación puntiforme, de la que sale pus. La madre refiere que durante este año ha presentado 3

episodios similares (el último hace 2 meses), los que han sido tratados con amoxicilina, con buena respuesta. ¿Qué antibiótico es el más adecuado?

a. Ninguno, solo necesita tratamiento sintomático
b. Amoxicilina
c. Amoxicilina + ácido clavulánico
d. Azitromicina
e. Clindamicina

Respuesta correcta: b. Amoxicilina

Explicación: Tiene una otitis media aguda recurrente (3 o más episodios de OMA en un año). La causa es la disfunción tubárica, por lo que no tiene relación con resistencia antibiótica y no es necesario hacer cambio alguno. Por tanto, se sigue indicando la amoxicilina, como tratamiento de elección. Lo que sí se debe hacer, es derivarlo al otorrinolaringólogo, para evaluar la necesidad de instalar tubos de ventilación y realizar una adenoidectomía. - La amoxicilina-clavulánico solo se indica en la OMA que no responde a 3 días de amoxicilina, aunque también es aceptable dejarla si recibió amoxicilina en los últimos 15 días. - La azitromicina se indica en alérgicos a la penicilina. * Eso sí, algunos sí recomiendan indicar amoxicilina-ácido clavulánico en las OMAR, incluso cuando ha pasado más de 15 días desde el uso de amoxicilina, pero son la minoría.

Fuente: Otorrinolaringología, cuestionario 2.2, P3

6. El diagnóstico de la otitis media crónica se basa en:

a. La audiometría
b. La historia clínica
c. La otoscopía
d. La impedanciometría
e. El TAC de oídos

Respuesta correcta: c. La otoscopía

Explicación: La OMC se ve como una perforación timpánica crónica en la otoscopía y se asocia a otorrea y leve hipoacusia crónicas.

Fuente: Otorrinolaringología, cuestionario 2.2, P17

7. Una paciente de 58 años, dibética, insulinorequiriente, consulta por otalgia derecha. Al examen físico se aprecia eritema del pabellón auricular y del conducto auditivo externo, asociado a otorrea abundante. La conducta más adecuada es:

a. Indicar ciprofloxacino tópico
b. Indicar amoxicilina oral
c. Indicar neomicina más bacitracina tópica
d. Indicar cloxacilina más clindamicina endovenosas
e. Indicar ceftazidima más amykacina endovenosas

Respuesta correcta: e. Indicar ceftazidima más amykacina endovenosas

Explicación: Tiene una otitis externa maligna (otorrea, otalgia y luego eritema de la oreja o la cara). Es una infección grave, causada por Pseudomona aureginosa, habitualmente en pacientes diabéticos o neutropénicos. Se trata con antibióticos endovenosos antipesudomona (ceftazidima, cefoperazona, cefepime o carbapenémicos, más tobramicina, amikacina o kanamicina).

Fuente: Otorrinolaringología, cuestionario 2.2, P18

8. Un niño de 2 años presenta retraso del lenguaje. A la otoscopía se observan ambos tímpanos opacos, por lo que se solicita una impedanciometría, que se muestra en la siguiente imagen: El diagnóstico es:

a. Otoesclerosis
b. Otitis media aguda
c. Otitis media crónica
d. Otitis media con efusión
e. Hipoacusia congénita

Respuesta correcta: d. Otitis media con efusión

Explicación: Tiene una curva B (plana), por lo que se confirma el diagnóstico de OME, que es la causa más frecuente de hipoacusia en los niños y se caracteriza por tímpanos rosados y opacos. La otoesclerosis tiene curva As (baja, con el vértice en el cero). La otitis media aguda (OMA) también tiene una curva B, pero su clínica es completamente diferente (fiebre, otalgia e irritabilidad). La otitis media crónica (OMC) afecta a los adultos y no se hace impedanciometría, por tener una perforación timpánica.

Fuente: Otorrinolaringología, cuestionario 2.3, P3

9. Un niño de 10 años presenta otalgia muy intensa, que inició dos días después de haberse bañado en la piscina. A la otoscopía se aprecia conducto auditivo externo eritematoso, con erosiones y otorrea purulenta. El tímpano no presenta alteraciones. La conducta más adecuada es:

a. Realizar lavado de oídos
b. Iniciar amoxicilina oral
c. Iniciar analgésicos orales y prohibir que se moje el oído hasta la resolución espontánea
d. Iniciar antibióticos tópicos y analgésicos por vía oral
e. Hospitalizar e iniciar antibióticos endovenosos

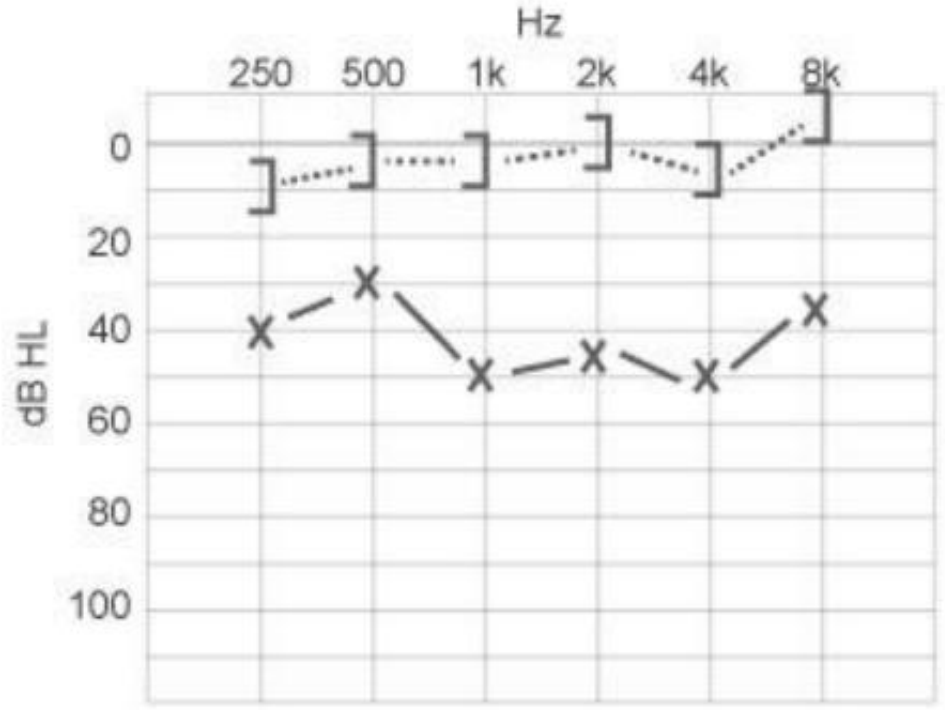
Respuesta correcta: d. Iniciar antibióticos tópicos y analgésicos por vía oral

Explicación: El diagnóstico es una otitis externa, probablemente por pseudomona, tanto por el antecedente de exposición a piscinas, como por la otoscopía y clínica. Se trata con antibióticos tópicos (generalmente ciprofloxacino o aminoglicósidos) y analgésicos. Se previene evitando que entre agua a los oídos (se llama otitis del nadador) y con lavados con ácido bórico después de nadar.

Fuente: Otorrinolaringología, cuestionario 2.3, P4

Hipoacusia y estudio auditivo (6)

10. Paciente de 45 años de edad, con antecedente de hipertensión arterial en tratamiento con enalapril, consulta por presentar hipoacusia progresiva, mayor a izquierda. La otoscopía, así como el resto de su examen físico, es normal. Se solicita una audiometría que se muestra a continuación. (NOTA: solo se muestra la audiometría del oído izquierdo, sin embargo, la del oído derecho es similar) El diagnóstico más probable es:



a. Neurinoma del acústico
b. Otitis media crónica
c. Presbiacusia
d. Otoesclerosis
e. Ototoxicidad

Respuesta correcta: d. Otoesclerosis

Explicación: La imagen muestra una hipoacusia de conducción (la vía aérea cae, pero la vía ósea se mantiene normal). Dentro de las opciones, solo la otitis media crónica (OMC) y la otoesclerosis son de conducción (las demás son hipoacusias sensorioneurales). Sin embargo, la OMC tiene alterada la otoscopía (habitualmente con una perforación timpánica), por lo que la respuesta correcta es otoesclerosis, que, por cierto, es la causa más frecuente de hipoacusia de conducción, con tímpano sano.

Fuente: Otorrinolaringología, cuestionario 2.1, P4

11. Se desea hacer screening de hipoacusia congénita a un recién nacido, con antecedente de ser hijo PEG y prematuro. La conducta más adecuada es:

a. Solicitar potenciales evocados auditivos
b. Solicitar audiometría
c. Solicitar impedanciometría

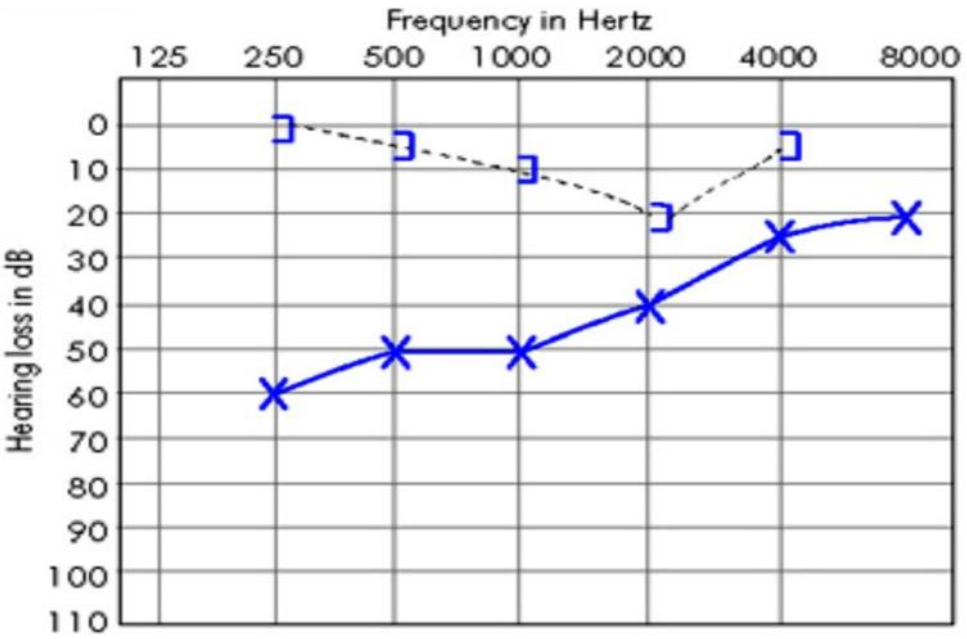
d. Solicitar RMN de troncoencéfalo
e. Observar evolución hasta los 2 años

Respuesta correcta: a. Solicitar potenciales evocados auditivos

Explicación: El gold standard para el screening de hipoacusia congénita son los potenciales evocados automáticos o BERA. Como alternativas más baratas están las emisiones otoacústicas (EOA), pero si están alteradas, se deben confirmar con los potenciales evocados. La confirmación definitiva se realiza con potenciales evocados clínicos, realizados por un técnico especializado, entrenado para ello.

Fuente: Otorrinolaringología, cuestionario 2.1, P7

12. Un paciente de 35 años consulta por hipoacusia bilateral, mayor a derecha. Al examen físico se constata dicha hipoacusia y se objetiva una otoscopía normal. El test de Weber lateraliza a la derecha y se realiza una audiometría, que se muestra a continuación. El diagnóstico más probable es:



a. Sordera súbita
b. Otitis media crónica
c. Otitis media con efusión
d. Presbiacusia precoz
e. Otoesclerosis

Respuesta correcta: e. Otoesclerosis

Explicación: La audiometría muestra una hipoacusia de conducción, ya que la vía aérea cayó, pero la vía ósea está normal (escucha sobre los 20 dB). De las opciones, solo la otitis media crónica (OMC), la otitis media con efusión (OME) y la otoesclerosis son de conducción. En cambio, sordera súbita y prebiacusia son sensorioneurales. El paciente tiene la otoscopía normal, por lo que no puede ser la OMC. Además, por ser adulto, es improbable que sea una OME. En adultos, la otoesclerosis es la causa más frecuente de hipoacusia de conducción con tímpano sano. * Recordar, eso sí, que el tímpano sano es característico de las hipoacusias sensorioneurales, por lo que la otoesclerosis es la excepción.

Fuente: Otorrinolaringología, cuestionario 2.2, P6

13. Un niño de 2 años presenta retraso del lenguaje. Además, su madre cree que no oye bien. Se realiza otoscopia, que muestra los tímpanos opacos. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

a. Solicitar audiometría
b. Solicitar impedanciometría
c. Indicar audífono
d. Solicitar VERA y emisiones otoacústicas
e. Indicar antibióticos orales y controlar en un mes

Respuesta correcta: b. Solicitar impedanciometría

Explicación: Se sospecha una otitis media con efusión (OME), dado que tiene hipoacusia y tímpanos opacos (en niño). Se estudia con impedanciometría, que suele mostrar curvas B o Cs. La audiometría no se puede hacer a los 2 años, ya que requiere de cooperación del niño (generalmente desde los 4-6 años, dependiendo del niño). Si la otoscopia hubiese estado normal, hubiese sido correcto solicitar los potenciales evocados. Además, actualmente se recomienda realizar evaluación de desarrollo en todo niño con retraso de lenguaje, ya que incluso si hay hipoacusia, es posible que haya otra condición de base, como la condición del espectro autista, que requiere intervención precoz.

Fuente: Otorrinolaringología, cuestionario 2.2, P13

14. La madre de un recién nacido prematuro solicita realizar alguna prueba para evaluar la audición del niño, ya que un pediatra amigo se lo recomendó. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

a. Solicitar audiometría
b. Solicitar potenciales evocados auditivos
c. Solicitar impedanciometría
d. Solicitar audiometría, impedanciometría y potenciales evocados auditivos
e. En este caso, no es necesario solicitar ningún examen para evaluar la audición

Respuesta correcta: b. Solicitar potenciales evocados auditivos

Explicación: El gold standard para el screening de hipoacusia congénita son los potenciales evocados o BERA. Como alternativas más baratas están las emisiones otoacústicas (EOA), pero si están alteradas, se deben estudiar con los potenciales evocados. En caso de que los BERA automáticos estén alterados, el examen de elección para confirmar son los potenciales evocados clínicos o BERA clínicos, que son realizados por un técnico especializado. La audiometría no se puede hacer en lactantes, ya que requieren de la cooperación del niño (apretar un botón al escuchar un ruido).

Fuente: Otorrinolaringología, cuestionario 2.2, P15

15. Un paciente presenta hipoacusia izquierda. En las pruebas de diapasones la prueba de Weber lateraliza a la izquierda. ¿Cuál de los siguientes diagnósticos es más probable?

a. Otoesclerosis izquierda
b. Otitis media crónica derecha
c. Presbiacusia izquierda
d. Trauma acústico derecho
e. Sordera súbita izquierda

Respuesta correcta: a. Otoesclerosis izquierda

Explicación: La prueba de Weber, normalmente no lateraliza. En las hipoacusias de conducción lateraliza al lado enfermo (como en este caso). En las hipoacusias sensorioneurales lateraliza al lado sano. El caso se

trata de una hipoacusia de conducción (otoesclerosis y OME son las únicas dos opciones), del lado izquierdo, por lo que la respuesta debe ser la otoesclerosis izquierda.

Fuente: Otorrinolaringología, cuestionario 2.3, P2

Vértigo (4)

16. Un paciente presenta vértigo de 3 días de evolución, de inicio súbito, muy intenso, asociado a vómitos, con lateropulsiones a derecha y un nistagmo de reposo, horizontal, con fase rápida a izquierda, muy marcado. No tiene signos cerebelosos, compromiso de otros pares craneanos ni alteraciones sensitivas o motoras. No presenta síntomas auditivos. El diagnóstico más probable es:

a. Vértigo postural paroxístico benigno
b. Neurinoma del acústico
c. Enfermedad de Ménière
d. Neuronitis vestibular
e. Accidente vascular

Respuesta correcta: d. Neuronitis vestibular

Explicación: Tiene un vértigo periférico, muy intenso y persistente, por lo que lo más probable es que tenga una neuronitis vestibular (se trata con corticoides). - El VPPB se relaciona con los movimientos de la cabeza y solo dura algunos segundos. Se trata con maniobras de reposición. - La enfermedad de Ménière tiene vértigo, más tinitus e hipoacusia, generalmente fluctuantes. Se trata con betahistina. - El neurinoma del acústico también suele tener estos síntomas, solo que más progresivos. - El accidente vascular tendría un vértigo de tipo central: nistagmo multidireccional, pulsiones multilaterales y signos cerebelosos. Su tratamiento es complejo y depende del tipo de accidente vascular (isquémico vs hemorrágico).

Fuente: Otorrinolaringología, cuestionario 2.1, P13

17. Un paciente de 58 años, con antecedente de hipertensión arterial, consulta por vértigo de una hora de evolución, asociado a imposibilidad de caminar. Al examen físico, se aprecia nistagmo multidireccional, asociado a tendencia a caer hacia ambos lados y hacia adelante. El diagnóstico más probable es:

a. Accidente vascular encefálico
b. Neuronitis vestibular
c. Enfermedad de Ménière
d. Neurinoma del acústico
e. Vértigo postural paroxístico benigno

Respuesta correcta: a. Accidente vascular encefálico

Explicación: Dado que tiene nistagmos multidireccional y lateropulsiones bilaterales, con anteropulsiones, tiene un vértigo central. La causa más frecuente es el accidente vascular encefálico. Las demás son causas de vértigo periférico. El vértigo periférico, en cambio, tiene nistagmos unidireccional, con tendencia a caer hacia el lado enfermo y no tiene signos cerebelosos (dismetría, adiadococinecia y ataxia).

Fuente: Otorrinolaringología, cuestionario 2.2, P1

18. Un paciente presenta vértigo muy intenso, de algunos segundos de duración, que aparece al realizar movimientos de la cabeza, como al levantarse de la cama. ¿Cuál de los siguientes fármacos es más útil para el manejo de este paciente?

a. Difenidol
b. Diltiazem

c. Prednisona
d. Fluoxetina
e. Pregabalina

Respuesta correcta: a. Difenidol

Explicación: Es una pregunta muy discutible, ya que la clínica es ce vértigo postural paroxístico benigno (VPPB), que generalmente no se trata con fármacos, sino con maniobras de reposición. Sin embargo, de las opciones, el único antivertiginoso es el difenidol y los antivertiginosos sí se pueden indicar en el VPPB. Eso sí, actualmente los antivertiginosos que más se usan en los ataques de vértigo severos son los antihistamínicos, en especial la meclizina y las benzodiacepinas, en especial el lorazepam.

Fuente: Otorrinolaringología, cuestionario 2.2, P14

19. Un paciente de 45 años presenta sensación de oído tapado desde hace 5 días, asociado a acúfeno de baja tonalidad. Hace 24 horas inicia vértigo intenso, con dificultades para caminar y tendencia a caerse al lado derecho. Al examen físico destaca nistagmo con fase rápida a izquierda, que disminuye al pedirle que fije la mirada en un punto. El diagnóstico más probable es:

a. Vértigo postural paroxísico benigno
b. Enfermedad de Ménière
c. Neuronitis vestibular
d. Neurinoma del acústico
e. Vértigo central

Respuesta correcta: b. Enfermedad de Ménière

Explicación: Tiene una enfermedad de Ménière clásica, con la triada de vértigo, hipoacusia y tinitus (o acúfeno). Se produce por un hídrops endolinfático y su diagnóstico es clínico, aunque se estudia con examen de VIII par y eventualmente con una RMN para descartar neurinoma del acústico. Su tratamiento es sintomático, con antivertiginosos (betahistina y, durante la crisis, se suelen agregar benzodiacepinas). Vale la pena mencionar que el problema es del oído derecho, ya que se cae hacia el lado enfermo y el nistagmo “escapa de la lesión”.

Fuente: Otorrinolaringología, cuestionario 2.3, P9

Nariz y senos paranasales (11)

20. Un paciente de 12 años de edad, con antecedente de dermatitis atópica, consulta por cuadro de 2 años de evolución de obstrucción nasal, asociada a rinorrea y epistaxis intermitentes. Al examen físico no hay hallazgos patológicos. La causa más probable de este caso es:

a. Cáncer nasosinusal
b. Nasofibroangioma
c. Rinitis alérgica
d. Cuerpo extraño nasal
e. Sinusitis crónica

Respuesta correcta: c. Rinitis alérgica

Explicación: Es una rinitis alérgica clásica, tanto por el antecedente de atopía, como por la clínica de obstrucción nasal, rinorrea y epistaxis (la rinitis alérgica es la causa más frecuente de esos 3 síntomas). El cáncer nasosinusal afecta a adultos fumadores y tiene obstrucción y espistaxis unilateral progresivas. El nasofibroangioma afecta a adolescentes y tiene obstrucción y marcada epistaxis progresiva. El cuerpo

extraño nasal tiene rinorrea purulenta y pútrida unilateral. La sinusitis crónica tiene rinorrea purulenta, descarga posterior, hiposmia, obstrucción nasal, cefalea, fiebre y sensación de presión facial.

Fuente: Otorrinolaringología, cuestionario 2.1, P1

21. Paciente de 24 años, sin antecedentes, sufre caída golpeándose la cara presentando epistaxis moderada. Al examen físico se encuentra deformidad nasal, equimosis en ambos pómulos y a la especuloscopía nasal se aprecia engrosamiento del septum. La conducta más adecuada en este caso es:

a. Solicitar radiografía de cara y observar
b. Taponar y realizar reducción de fractura inmediatamente
c. Taponar y realizar reducción de fractura de forma diferida
d. Realizar drenaje quirúrgico y taponar
e. Solicitar TAC de cara y taponar

Respuesta correcta: d. Realizar drenaje quirúrgico y taponar

Explicación: El engrosamiento del septum sugiere un hematoma septal, el que requiere drenaje urgente, mediante incisión amplia, ya que se complica con necrosis avascular del cartílago septal. Se recomienda dejar amoxicilina, junto al taponamiento, pero no es obligatorio, a menos que tenga signos de infección.

Fuente: Otorrinolaringología, cuestionario 2.1, P6

22. Un adolescente de 15 años presenta un cuadro de coriza y odinofagia, asociada a decaimiento que inició hace 2 días. Al examen se palpan algunas adenopatías cervicales sensibles, faringe eritematosa, con amígdalas aumentadas de tamaño, sin exudado. Resto del examen físico es normal. El diagnóstico más probable es:

a. Angina de Vincent
b. Resfrío común
c. Mononucleosis infecciosa
d. Adenitis supurada
e. Amigdalitis pultácea

Respuesta correcta: b. Resfrío común

Explicación: Es un resfrío común y corriente. También se puede ver como una faringoamigdalitis de características virales, ya que tiene síntomas catarrales (coriza), no tiene odinofagia especialmente intensa y no tiene exudado.

Fuente: Otorrinolaringología, cuestionario 2.1, P16

23. Un paciente de 60 años presenta un cuadro de 3 meses de evolución de sensación de presión facial, secreción nasal purulenta y descarga posterior, asociado a disminución del olfato y obstrucción nasal. Se debe iniciar estudio con:

a. Nasofobroscopía
b. TAC de cavidades paranasales
c. Radiografía de cavidades paranasales
d. Manometría nasal
e. Cultivo de secreción nasal

Respuesta correcta: b. TAC de cavidades paranasales

Explicación: La clínica es de una sinusitis. Además, por llevar 3 meses (más de 12 semanas) es crónica. Aunque el diagnóstico es predominantemente clínico, la sinusitis crónica se debe estudiar con una TAC de

senos paranasales, tanto para apoyar el diagnóstico como, especialmente, para ver si existe alguna causa anatómica que la explique.

Fuente: Otorrinolaringología, cuestionario 2.1, P17

24. Un paciente de 18 años presenta epistaxis derecha de 3 meses de evolución, que ha sido intermitente, pero que ha aumentado de frecuencia. Además, refiere que hace 1 mes siente la fosa nasal derecha totalmente tapada. No fuma, ni consume sustancias y no refiere otras molestias. Consulta ahora por epistaxis, que empezó hace 30 minutos y que no ha parado. El diagnóstico más probable es:

a. Cáncer nasal
b. Cuerpo extraño nasal
c. Nasofibroangioma
d. Sinusitis crónica
e. Mucormicosis

Respuesta correcta: c. Nasofibroangioma

Explicación: Es un nasofibroangioma clásico: adolescente con obstrucción nasal y epistaxis ipsilateral progresivas. Es un tumor benigno, que se debe manejar quirúrgicamente, para evitar que siga sangrando. El cáncer nasal afecta a adultos, generalmente fumadores, con obstrucción nasal y secreción serosanguinolenta. Además, puede invadir la órbita y producir todo tipo de molestias oculares (proptosis, estrabismo). El cuerpo extraño nasal produce rinorrea pútrida unilateral. La mucormicosis presenta una sinusitis muy agresiva, necrosante, con visualización de hifas de hongos o bien, con necrosis de la nariz o la cara. Suele afectar a diabéticos y pacientes neutropénicos.

Fuente: Otorrinolaringología, cuestionario 2.2, P4

25. Un paciente de 17 años consulta por rinorrea acuosa, asociada a obstrucción nasal bilateral, de dos algunos años de evolución, pero que ha aumentado en el último mes. Refiere prurito nasal y al examen físico se aprecia ojeroso, con mucosa nasal pálida. La conducta más adecuada es:

a. Indicar vasoconstrictores nasales tópicos
b. Iniciar corticoides tópicos nasales
c. Solicitar flujometría nasal
d. Iniciar clorfenamina oral
e. Solicitar prick test, eosinófilos nasales y niveles plasmáticos de IgE

Respuesta correcta: b. Iniciar corticoides tópicos nasales

Explicación: El diagnóstico es una rinitis alérgica con clínica clásica (rinorrea, obstrucción, prurito y signos de atopía, con mucosa pálida). Por tanto, el diagnóstico está confirmado. El tratamiento suele ser con antihistamínicos H1 orales (más fáciles de usar) o con corticoides tópicos (más eficaces). Si los síntomas son graves o si hay obstrucción nasal, como en este caso, se prefieren los corticoides tópicos, como tratamiento de primera línea.

Fuente: Otorrinolaringología, cuestionario 2.2, P8

26. Un paciente de 35 años consulta por rinorrea mucosa, tos, sensación de descarga posterior e hiposmia, de 2 días de evolución, asociado a cefalea, que aumenta al agacharse. El examen físico no aporta mayor información. La conducta más adecuada es:

a. Solicitar TAC de cavidades paranasales
b. Iniciar tratamiento sintomático

c. Indicar amoxicilina oral por 14 días
d. Indicar clindamicina oral por 10 días
e. Indicar cefuroximo oral por 10 a 14 días

Respuesta correcta: b. Iniciar tratamiento sintomático

Explicación: Tiene clínica de una sinusitis, por lo que el diagnóstico es sinusitis, puesto que es de diagnóstico clínico. Además, por tener menos de 4 semanas, es una sinusitis aguda. Por tener menos de 1 semana, es de etiología viral, por lo que se trata sintomáticamente. Si tuviese más de 7-10 días y no mejora o si inicialmente mejoró, pero luego empeora, se sospecharía que es bacteriana y se trataría con antibióticos por 14 días (amoxicilina es de elección, aunque es aceptable dejar amoxicilina más ácido clavulánico, cefuroximo, cefixima, cefpodoxima o incluso doxiciclina). También sugiere que sea bacteriana la visualización de pus saliendo por el meato medio. Finalmente, las complicadas con abscesos son bacterianas, independientemente del tiempo de evolución.

Fuente: Otorrinolaringología, cuestionario 2.2, P10

27. Un paciente de 30 años consulta por epistaxis izquierda abundante, de 20 minutos de evolución. Usted realiza compresión nasal por 15 minutos, sin lograr que la epistaxis pare. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

a. Realizar lavados con suero fisiológico intranasal
b. Aplicar vasoconstrictores nasales
c. Realizar taponamiento posterior
d. Realizar taponamiento anterior
e. Comprimir por 15 minutos más y reevaluar

Respuesta correcta: d. Realizar taponamiento anterior

Explicación: El orden del manejo de la epistaxis es 1. Compresión nasal (se puede agregar oximetazolina o adrenalina tópicas, como vasoconstrictores), 2. Cauterizar con nitrato de plazo, mediante rinoscopía directa, 3. Taponamiento anterior y 4. Taponamiento posterior. Si no responde, se hacen cosas más invasivas.

Fuente: Otorrinolaringología, cuestionario 2.2, P12

28. Un niño de 6 años presenta un cuadro compatible con una rinosinusitis aguda. Evoluciona con eritema periocular izquierdo, asociado limitación de los movimientos de dicho ojo. El diagnóstico más probable es:

a. Infección por adenovirus
b. Rinitis alérgica, asociada a conjuntivitis alérgica
c. Obstrucción del conducto nasolacrimal
d. Celulitis orbitaria
e. Celulitis preorbitaria

Respuesta correcta: d. Celulitis orbitaria

Explicación: Las celulitis orbitaria y preorbitaria son las complicaciones más frecuentes de las sinusitis bacterianas. Ambas tienen eritema y edema periocular. La orbitaria, además, tiene oftalmoplejía u oftalmoparesia (como en este caso), proptosis, quemosis y disminución de la agudeza visual y de los reflejos fotomotor y de acomodación. Por la sola oftalmoparesia ya es orbitaria. Se debe hospitalizar, estudiar con una TAC de órbitas y cavidades paranasales y tratar con antibióticos endovenosos de amplio espectro: Ej. ceftriaxona más vancomicina y algunos agregan metronidazol. * Nótese que actualmente se

recomienda la vancomicina en toda infección grave en las que el S. aureus sea uno de los gérmenes frecuentes.

Fuente: Otorrinolaringología, cuestionario 2.2, P19

29. Un paciente de 63 años consulta por obstrucción nasal derecha, progresiva, asociada a rinorrea purulenta y epistaxis frecuente, síntomas que iniciaron hace cerca de 5 meses. El diagnóstico más probable es:

a. Poliposis nasal
b. Sinusitis crónica
c. Nasofibroangioma nasal
d. Cáncer nasosinusal
e. Cuerpo extraño nasal

Respuesta correcta: d. Cáncer nasosinusal

Explicación: Es la historia clásica del cáncer nasosinusal (adulto mayor, con obstrucción progresiva y con epistaxis ipsilateral). La poliposis nasal suele ser en pacinetes alérgicos, con marcada obstrucción bilateral y sinusitis a repetición. El nasofibroangioma suele afectar a adolescentes, con obstrucción unilateral y epistaxis ipsilateral (si hubiese sido adolescentes, esta habría sido la respuesta correcta). El cuerpo extraño nasal produce rinorrea purulenta unilateral.

Fuente: Otorrinolaringología, cuestionario 2.3, P7

30. Un paciente de 30 años presenta un cuadro de cefalea, rinorrea purulenta y descarga posterior, asociado a hiposmia y obstrucción nasal de 2 semanas de evolución. La conducta más adecuada es:

a. Diagnosticar sinusitis aguda e iniciar tratamiento antibiótico
b. Solicitar TAC de cavidades paranasales y decidir conducta según resultado
c. Diagnosticar cuerpo extraño nasal y derivar a otorrinolaringología
d. Diagnosticar rinosinusitis viral e iniciar tratamiento sintomático
e. Diagnosticar sinusitis subaguda e iniciar amoxicilina + ácido clavulánico

Respuesta correcta: a. Diagnosticar sinusitis aguda e iniciar tratamiento antibiótico

Explicación: Tiene una sinusitis clínica, por lo que tiene sinusitis. Además, por tener menos de 4 semanas, es aguda (la subaguda es entre 4 y 12 semanas y la crónica es mayor a 12 semanas). Además, por tener 14 días, lo más probable es que sea bacteriana y no viral (menor a 7 días son virales), por lo que se debe tratar con antibióticos (amoxicilina oral). El TAC de cavidades paranasales se puede pedir, pero la indicación más importante es que tenga más de 4 semanas, es decir, que sea subaguda o crónica (para buscar una causa anatómica), ya que el diagnóstico de sinusitis es clínico y la TAC es solo un elemento más a considerar.

Fuente: Otorrinolaringología, cuestionario 2.3, P8

Faringe y amígdalas (6)

31. Paciente de 7 años, de edad, sin antecedentes, consulta por cuadro de fiebre de 1 día de evolución asociado a gran odinofagia, sin otros síntomas. Al examen físico se aprecia decaído, sudoroso, faringe eritematosa, amígdalas con placas grisáceas, sin otros hallazgos. El fármaco de elección para el tratamiento de este caso es:

a. Clindamicina
b. Amoxicilina

c. Acetaminofeno
d. Prednisona
e. Levofloxacino

Respuesta correcta: b. Amoxicilina

Explicación: Es una amigdalitis estreptocócica, ya que tiene odinofagia intensa de rápida instalación, fiebre, exudado y ausencia de síntomas catarrales (tos, rinorrea o disfonía). Se trata con amoxicilina. Si fuera alérgico, los macrólidos serían de elección, aunque la clindamicina sería una buena opción. Desde la óptica de los criterios de Centor (1. Tº > 38º, 2. exudado o hipertrofia, 3. adenopatías, 4. ausencia de síntomas catarrales y 5. edad 3-15 años), tiene 4 0-1 punto: tratamiento sintomático. 2-3 puntos: prueba de detección de SGA. Tratar si positiva. 4-5 puntos: tratar.

Fuente: Otorrinolaringología, cuestionario 2.1, P2

32. Paciente de 35 años de edad, soltero, con antecedentes de hipertensión arterial y obesidad, consulta por cuadro de fatigabilidad matinal de meses de evolución, asociado a hipersomnia. Su examen físico no aporta mayor información. ¿Cuál es la conducta más adecuada con este paciente?

a. Solicitar polisomnograma
b. Indicar C-PAP nocturno
c. Indicar metilfenidato en las mañanas
d. Solicitar nasofibroscopía
e. Realizar amigdalectomía bilateral

Respuesta correcta: a. Solicitar polisomnograma

Explicación: La sospecha es un SAHOS (síndrome de apnea hipopnea obstructiva del sueño), ya que tiene obesidad e hipersomnia. De elección, se debe estudiar con una polisomnografía, ya que la clínica tiene mal rendimiento para diagnosticar y evaluar el SAHOS. La polisomnografía idealmente se debe hacer con titulación de C-PAP. Los test de SAHOS en el hogar son una opción aceptable y más barata, pero solo si se sospecha que un SAHOS moderado o severo (tiene mala sensibilidad en SAHOS leve), no complicado y sin sospecha de otras patologías (ej. narcolepsia) ni trabajos de alto riesgo (ej. chofer de un buso piloto).

Fuente: Otorrinolaringología, cuestionario 2.1, P10

33. Un niño de 8 años consulta por odinofagia intensa, asociada a malestar general de un día de evolución, sin otros síntomas. Al examen físico está decaído, con fiebre de 38,8 grados Cesius y se observa la faringe eritematosa, con pequeñas placas blanquecinas en ambas amígdalas, que ocupan los surcos amigdalinos. La conducta más adecuada es:

a. Iniciar tratamiento sintomático
b. Iniciar amoxicilina más ácido clavulánico oral
c. Iniciar amoxicilina oral
d. Solicitar cultivo faríngeo
e. Solicitar serología para virus Ebstein Baar (IgM VCA)

Respuesta correcta: c. Iniciar amoxicilina oral

Explicación: Tiene una clínica muy sugerente de amigdalitis pultácea o estreptocócica: exudado en los surcos, odinofagia intensa, sin signos catarrales y con fiebre. Se trata con amoxicilina oral. Desde el punto de vista de los criterios de Centor (1. Fiebre >38ºC, 2. Adenopatías cervicales, 3. Edad 3-15 años, 4. Ausencia de signos catarrales, 5. Exudado o hipertrofia amigdalina), tiene 4 puntos, por lo que se debe tratar con antibióticos. - Si hubiese tenido 0 o 1 punto, se trata sintomáticamente, ya que probablemente

es viral. - Si hubiese tenido 2 o 3 puntos, se debe pedir una prueba confirmatoria (generalmente test rápido por ser inmediato, más cultivo, por tener una mayor sensibilidad). Si la prueba está positiva, se trata con antibióticos. Si está negativa, solo se indica tratamiento sintomático. La decisión inicial se suele hacer con la prueba rápida y la decisión final se realiza con el cultivo faríngeo, que suele demorar 2 días en tener un resultado.

Fuente: Otorrinolaringología, cuestionario 2.2, P5

34. Un niño de 12 años consulta por odinofagia muy intensa, asociada a imposibilidad de masticar y de tragar. Al examen físico presenta dolor a la apertura mandibular y se observa faringe eritematosa, con exudado amigdalino. La amígdala derecha está desplazada hacia medial y se aprecia aumento de volumen, en relación al pilar amigdalino derecho. La conducta más adecuada es:

a. Solicitar ecografía cervical
b. Solicitar TAC de cuello
c. Solicitar resonancia magnética nuclear
d. Enviar a domicilio con amoxicilina oral
e. Inyectar una dosis de penicilina benzatina y enviar a domicilio

Respuesta correcta: b. Solicitar TAC de cuello

Explicación: El diagnóstico de sospecha es un absceso periamigdalino (trismus, dolor y abombamiento del pilar amigdalino anterior). Se debe estudiar con una TAC de cuello y luego se trata con drenaje quirúrgico, en pabellón, bajo cobertura antibiótico, con antibióticos de amplio espectro (ejemplo: ceftriaxona más clindamicina).

Fuente: Otorrinolaringología, cuestionario 2.2, P9

35. Un adolescente de 15 años presenta un cuadro de odinofagia intensa, asociada a fiebre hasta 39°C, que inició hace 24 horas. Al examen se palpan algunas adenopatías cervicales sensibles, se aprecia una faringe muy eritematosa, con amígdalas aumentadas de tamaño, con placas múltiples, bilaterales, en las criptas, de color blanquecino y visualización de petequias en el paladar blando. El agente etiológico más probable es:

a. Citomegalovirus
b. Bacterias anaerobias
c. Estreptococo betahemolítico, grupo A
d. Virus de Ebstein Baar
e. Rinovirus

Respuesta correcta: c. Estreptococo betahemolítico, grupo A

Explicación: La clínica es muy sugerente de una amigdalitis bacteriana o estreptocócica (fiebre alta, dolor intenso, adenopatías, exudado, petequias y ausencia de signos catarralaes). Tiene los 5 puntos del score de Centor. - El CMV y el VEB producen síndromes mononucleósicos, que también tienen odinofagia, fiebre y adenopatías, pero además, hepatoesplenomegalia, ictericia, linfocitosis, y tienen un exudado blanco grande, en la superficie de las amígdalas (no en los surcos). Además, suelen presentarse de manera subaguda. - Los anaerobios producen la angina de Vincent o úlcero necrótica, con marcada gingivitis, halitosis y úlceras y necrosis de las amígdalas y paladar. - El rinovirus produce un resfrío común, con síntomas catarrales (rinorrea, tos y disfonía).

Fuente: Otorrinolaringología, cuestionario 2.3, P5

36. Un niño de 4 años presenta un síndrome de apnea del sueño. Al examen físico se aprecia hipertrofia amigdalina grado IV. No ha tenido síntomas de amigdalitis. La conducta más adecuada es:

a. Derivar para amigdalectomía
b. Iniciar corticoides orales y revaluar
c. Iniciar AINEs orales y revaluar
d. Iniciar antibióticos orales y revaluar
e. Observar evolución

Respuesta correcta: a. Derivar para amigdalectomía

Explicación: La hipertrofia amigdalina se puede observar o bien operar. Entre las indicaciones de cirugía están la hipertrofia grado IV (en este caso), la apnea del sueño (también en este caso), la amigdalitis crónica y la asimetría amigdalina. 1.- Ojos rojos I

Fuente: Otorrinolaringología, cuestionario 2.3, P10

Laringe y disfonía (6)

37. Paciente de 30 años, profesor de colegio, consulta por presentar disfonía desde hace varios meses no asociado a otros síntomas. Refiere que cuando trabaja mucho, sus síntomas empeoran y que durante el reposo persiste con disfonía. La causa más probable en este caso es:

a. Nódulos cordales
b. Edema de Reinke
c. Cáncer laríngeo
d. Disfonía musculotensional
e. Parálisis vagal

Respuesta correcta: a. Nódulos cordales

Explicación: Por ser un profesor, lo más probable es que sea de tipo funcional, por abuso vocal. Tanto los nódulos cordales, como la disfonía muscolotensional son funcionales, pero esta última mejora prácticamente por completo al guardar reposo, mientras que los nódulos mantienen algún grado de disfonía, como en este caso. Se debe realizar una nasofibroscopía, ya que podría tratarse de otra causa.

Fuente: Otorrinolaringología, cuestionario 2.1, P5

38. Paciente de 5 años de edad, sin antecedentes, es traído por cuadro de tos ronca, mayor en la noche, asociado a irritabilidad y fiebre (38°C), al que luego se agrega dificultad respiratoria. Al examen físico se aprecia cianosis perioral, saturación arterial de oxígeno de 93%, estridor inspiratorio, uso de musculatura intercostal. El agente etiológico más probable es:

a. Virus parainfluenza
b. Haemophilus influenzae B
c. Neumococo
d. Streptococcus pyogenes
e. Staphilococcus aureus

Respuesta correcta: a. Virus parainfluenza

Explicación: Tiene una laringitis obstructiva clásica, que es causada por virus parainfluenza.

Fuente: Otorrinolaringología, cuestionario 2.1, P15

39. Un paciente de 50 años, con antecedente de tabaquismo crónico, presenta disfonía de varias semanas de evolución, la cual es constante sin variaciones con el uso excesivo de la voz. Al examen físico no presenta otras alteraciones. La conducta más adecuada es:

a. Solicitar TAC de cuello
b. Solicitar ecografía de cuello
c. Solicitar nasofibroscopía
d. Iniciar antibióticos orales y revaluar
e. Indicar reposo vocal y observar evolución

Respuesta correcta: c. Solicitar nasofibroscopía

Explicación: Toda disfonía crónica se estudia con nasofibroscopía. Más aun, en este caso, en que se sospecha un cáncer, dado que es fumador y que no varía con el uso vocal.

Fuente: Otorrinolaringología, cuestionario 2.1, P19

40. Un paciente de 59 años consulta por disfonía de un mes de evolución, que ha ido en aumento. También presenta tos y carraspera ocasional. ¿Qué examen es más adecuado para evaluarlo?

a. TAC de cuello
b. Ecografía de cuello
c. Test pack para virus parainfluenza
d. Videodeglución
e. Nasofibroscopía

Respuesta correcta: e. Nasofibroscopía

Explicación: Toda disfonía crónica se debe estudiar con una nasofibroscopía, dado que hay que descartar el cáncer y buscar las demás causas.

Fuente: Otorrinolaringología, cuestionario 2.2, P11

41. ¿Cuál es la causa más frecuente de la parálisis del nervio laríngeo recurrente?

a. Iatrogénica
b. Autoinmune
c. Cáncer
d. Isquémica
e. Idiopática

Respuesta correcta: a. Iatrogénica

Explicación: La causa más frecuente de afectación del nervio laríngeo recurrente es la cirugía de tiroides. Si es unilateral puede producir disfonía con voz bitonal. Si es bilateral, tiene riesgo de pérdida de la vía aérea.

Fuente: Otorrinolaringología, cuestionario 2.2, P20

42. Un paciente de 59 años presenta disfonía de varias semanas de evolución. Refiere que empeora al hablar mucho, pero que en general siempre tiene algún grado de disfonía. Al examen físico no presenta otras alteraciones. La conducta más adecuada es:

a. Solicitar TAC de cuello
b. Solicitar ecografía de cuello
c. Solicitar nasofibroscopía

d. Iniciar antibióticos orales y revaluar
e. Indicar reposo vocal y observar evolución

Respuesta correcta: c. Solicitar nasofibroscopía

Explicación: Todo paciente con disfonía crónica se debe estudiar con una nasofibroscopía, para determinar la causa y para descartar el cáncer.

Fuente: Otorrinolaringología, cuestionario 2.3, P6

Cuello, cavidad oral y deglución (3)

43. Paciente de 55 años, con antecedente de EPOC tabáquico en tratamiento, consulta por aparición de lesión en lengua que se muestra a continuación (fuente: https://www.sdpt.net/par/leucoplasiapilosa.htm). La conducta más adecuada en este caso es:

a. Mantener en observación
b. Solicitar hemograma y vhs
c. Realizar biopsia
d. Administrar nistatina tópica
e. Solicitar ELISA para VIH

Respuesta correcta: c. Realizar biopsia

Explicación: Tiene una leucoplaquia o leucoplasia. Suelen ser lesiones premalignas, e incluso puede tratarse de un cáncer. Por ello, se deben biopsiar y luego remover, mediante crioterapia o cirugía. Sí es correcto solicitar Elisa VIH, ya que se asocia a dicha patología y toda persona sexualmente activa se debe hacer dicho examen como screening, pero, en este caso tiene claro el antecedente de tabaquismo como causa y se pregunta el manejo de la leucoplasia, que es la biopsia.

Fuente: Otorrinolaringología, cuestionario 2.1, P3

44. Paciente de 10 años de edad, sin antecedentes, es traído por la aparición de aumento de volumen en cuello, de 2 meses de evolución, que se muestra a continuación: La causa más probable es:



a. Quiste branquial
b. Quiste conducto tirogloso
c. Lipoma cervical
d. Adenitis infecciosa
e. Quiste sebáceo

Respuesta correcta: a. Quiste branquial

Explicación: Es un quiste branquial clásico. Se presenta en niños y adolescentes (aunque está presente desde el nacimiento, solo que pequeño e imperceptible), ubicado en la zona lateral del cuello, generalmente en el borde anterior del músculo esternocleidomastoideo. - El quiste tirogloso es similar, pero ubicado en la línea media del cuello. - El lipoma es menos frecuente en el cuello, ya que suele estar en otras ubicaciones (ej. extremidades o espalda). - La adenitis infecciosa tendría signos inflamatorios, aunque los quistes también se pueden infectar, con la diferencia que en los quistes la infección suele ser una complicación posterior a la aparición del mismo (no siempre, ya que, en ocasiones se presentan como una absceso). - El quiste sebáceo suele tener un poro central, por que puede salir el material sebáceo, si es que se presiona.

Fuente: Otorrinolaringología, cuestionario 2.1, P14

45. Un paciente de 70 año, presenta un accidente vascular encefálico, que es manejado en la UCI, con buena evolución. Al realimentarlo con papilla presenta tos intensa, al tragar. La conducta más adecuada es:

a. Indicar régimen hídrico amplio
b. Instalar nutrición parenteral total a permanencia
c. Indicar régimen cero, alimentar por sonda nasogástrica y solicitar videodeglución
d. Indicar régimen sólido, agregando espesantes a los líquidos ingridos
e. Mantener la alimentación con papilla e iniciar antibióticos

Respuesta correcta: c. Indicar régimen cero, alimentar por sonda nasogástrica y solicitar videodeglución

Explicación: Tiene un trastorno de la deglución, secundario al accidente vascular encefálico. Se debe indicar régimen 0, para evitar la broncoaspiración. Además, se debe estudiar con una video-deglución (gold standard) y alimentar por otra vía (generalmente sonda nasogástrica, si es algo transitorio y no hay vómitos. Si se vuelve permanente se hace gastrostomía).

Fuente: Otorrinolaringología, cuestionario 2.2, P16

Cuerpos extraños en vía aérea y digestiva (4)

46. Paciente de 43 años de edad, sin antecedentes, consulta por cuadro de dos días de evolución de otalgia izquierda, asociada a hipoacusia ipsilateral que es fluctuante durante el día. A la otoscopía se observa una araña viva en el interior del conducto auditivo externo. La conducta inicial más adecuada es:

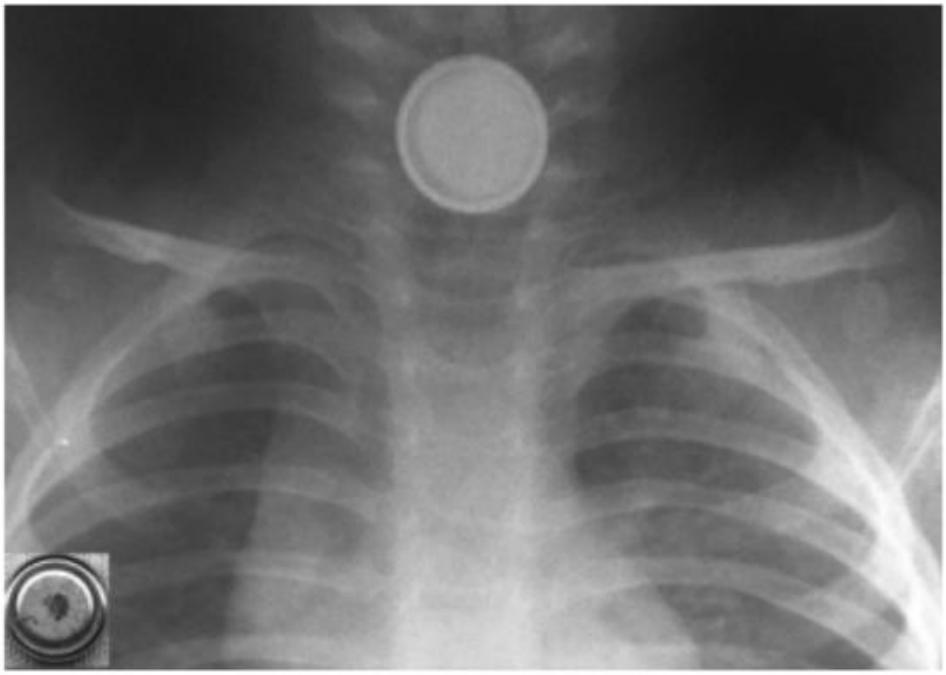
a. Retirar con pinzas
b. Retirar con suero fisiológico
c. Observar
d. Administrar insecticida por CAE
e. Retirar con vaselina líquida

Respuesta correcta: e. Retirar con vaselina líquida

Explicación: Por regla general, los cuerpos extraños óticos se derivan, con la excepción de un insecto vivo (en este caso un arácnido), lo que deben matarse con vaselina líquida, aceite vegetal o lidocaína y posteriormente derivarlo. El suero y el agua no logran matarlo, ya que, por la alta tensión superficial del agua, se forman burbujas y el insecto se mantiene vivo (pero agitado), lo que puede aumentar el daño. El insecticida tiene mucho riesgo.

Fuente: Otorrinolaringología, cuestionario 2.1, P11

47. Un niño de 1 año se traga una pila de reloj agrande, presentando llanto y dificultad para tragar. Se solicita una radiografía que muestra lo siguiente (fuente: https://www.researchgate.net/figure/Figura-4-Pila-boton-en-esofago-Imagen-de- doble-contorno_fig4_237016567): La conducta más adecuada es:



a. Realizar extracción endoscópica
b. Realizar TAC abdominal
c. Observar evolución e indicar control en una semana, o en caso de síntomas
d. Administrar lactulosa
e. Realizar radiografías de abdomen seriadas

Respuesta correcta: a. Realizar extracción endoscópica

Explicación: Se debe extraer, mediante endoscopía, tanto por ser una pila (las pilas grandes siempre se sacan, independiente de su localización; y las pilas pequeñas habitualmente se deben extraer también, aunque es algo más discutible), como por estar en el esófago (por la odinofagia y por verse en el cuello, en la radiografía). Todo cuerpo extraño esofágico se saca. En cambio, si estuviera en el estómago o intestino, se puede observar evolución y solo se extrae, si es que se complica (o si es una pila o imanes). El cuerpo extraño esofágico no se debe confundir con la impactación de comida en el esófago, cuyo manejo puede ser con la observación (si permite tragar líquidos, no tiene dolor ni signos de perforación y no pasa más de 24 horas), o bien, desimpactar con una endoscopía (si tiene cualquiera de los signos de alarma descritos).

Fuente: Otorrinolaringología, cuestionario 2.1, P20

48. Un niño de 3 años presenta rinorrea purulenta abundante por la fosa nasal derecha, desde hace dos días. El resto de su examen físico es normal. La conducta más adecuada es:

a. Indicar amoxicilina oral y controlar ambulatoriamente
b. Indicar corticoides en spray nasal y controlar ambulatoriamente
c. Observar evolución
d. Realizar irrigaciones con suero fisiológico, en la fosa nasal derecha
e. Derivar a otorrinolaringólogo

Respuesta correcta: e. Derivar a otorrinolaringólogo

Explicación: La sospecha es un cuerpo extraño nasal, por lo que se debe derivar, para confirmar su diagnóstico y para ser retirado por el especialista. El diagnóstico suele hacerse con una simple rinoscopía (mirar la nariz con un espéculo nasal y una buena luz), pero este procedimiento suele ser realizado por otorrinolaringólogo. La opción, si no se ve, suele ser la nasofibroscopía. En los casos en que la historia es muy sugerente y el diagnóstico lo realiza el médico general, se puede intentar con el paciente las maniobras de soplido unilateral (similar a como se sacan los mocos los futbolistas, tapando una fosa nasal y soplando fuertemente por la otra, hasta botar el cuerpo extraño).

Fuente: Otorrinolaringología, cuestionario 2.2, P7

49. Un niño se mete un poroto en el oído y no puede sacárselo. La otoscopía lo muestra en el conducto auditivo externo, a 1,5 cm del pabellón auricular. La conducta más adecuada es:

a. Observar evolución y esperar que caiga espontáneamente
b. Realizar lavado auricular
c. Solicitar impedanciometría
d. Retirar con una pinza balloneta
e. Derivar a otorrinolaringología de manera urgente

Respuesta correcta: e. Derivar a otorrinolaringología de manera urgente

Explicación: Los cuerpos extraños en el oído se deben derivar al otorrino, ya que la extracción por médico general, sin el instrumental adecuado tiene riesgo de lesionar el conducto auditivo. La única excepción son los insectos vivos, que se deben matar con vaselina líquida, lidocaína o aceite vegetal. El lavado auricular está contraindicado, ya que el cuerpo extraño puede absorber agua y aumentar de tamaño, incrementando el daño.

Fuente: Otorrinolaringología, cuestionario 2.3, P1

Urología (70)

Litiasis urinaria (5)

1. Un paciente de 35 años consulta por dolor lumbar izquierdo, muy intenso, irradiado al testículo ipsilateral. Además, ha vomitado en varias ocasiones. Al examen físico se aprecia sudoroso, cambia continuamente de posición y se queja continuamente. La conducta más adecuada para el tratamiento del paciente descrito es:

a. Administrar suero fisiológico endovenoso
b. Administrar ketorolaco endovenoso
c. Administrar haloperidol endovenoso
d. Enviar a domicilio con paracetamol oral
e. Resolver quirúrgicamente

Respuesta correcta: b. Administrar ketorolaco endovenoso

Explicación: Tiene un cólico renal clásico. El diagnóstico es clínico y su tratamiento, en agudo, consiste en analgesia endovenosa o intramuscular (generalmente AINEs), más antieméticos, en caso de vómitos. Se debe solicitar un pieloTAC para determinar el manejo posterior. El pieloTAC no usa contraste y tiene baja radiación, en comparación con un TAC convencional. - Si > 10 mm: derivar a urólogo para LEC (litotripsia extracorpórea o similares). - Si > 5 mm y ≤ 10 mm: observar, pero agregar tamsulosina u otro alfabloqueante. - Si ≤ 5 mm: observar (se eliminan espontáneamente). La eliminación se confirma con la salida del cálculo (ej. orinar en un colador) y, si no se objetiva, mediante un nuevo pieloTAC. Si no se elimina en 4 semanas, se deriva para su remoción.

Fuente: Urología, cuestionario 6.1, P3

2. ¿Cuál de las siguientes indicaciones es MENOS útil para prevenir la recurrencia de una litiasis renal?

a. Aumentar la ingesta diaria de agua
b. Disminuir la ingesta de proteínas de origen animal, si es una litiasis por oxalato de calcio
c. Disminuir la ingesta de calcio, si es una litiasis por oxalato de calcio
d. Indicar alopurinol, si es una litiasis por ácido úrico
e. Indicar diuréticos tiazídicos, si está asociada a hipercalciuria idiopática

Respuesta correcta: c. Disminuir la ingesta de calcio, si es una litiasis por oxalato de calcio

Explicación: Es una pregunta discutible, ya que, en estricto rigor, la respuesta dependerá del trastorno metabólico asociado. Sin embargo, la regla general es que el calcio oral quela al oxalato y disminuir la ingesta de calcio incluso puede aumentar el riesgo de litiasis, además del riesgo de osteoporosis. Lo más importante es aumentar la ingesta de agua, pero también sirven las demás medidas enumeradas en las opciones B, D y E.

Fuente: Urología, cuestionario 6.1, P15

3. Un paciente de 34 años presenta un cólico renal, que es manejado adecuadamente, con analgesia. Se solicita un pieloTAC que muestra un cálculo de 2 cm de diámetro en relación al uréter derecho. El sedimento de orina muestra cristales de oxalato de calcio. ¿Cuál es la conducta más adecuada para el manejo de esta litiasis, una vez que haya disminuido el dolor?

a. Indicar diuréticos tiazídicos a permanencia
b. Resolver quirúrgicamente

c. Realizar litotripsia extracorpórea
d. Indicar bicarbonato de sodio oral
e. Indicar carbonato de calcio oral

Respuesta correcta: c. Realizar litotripsia extracorpórea

Explicación: Una vez resuelto el cólico renal (cuadro agudo de dolor y vómitos), es necesario eliminar el cálculo. El tratamiento dependerá del tamaño: - Si > 10 mm: derivar a urólogo para LEC (litotripsia extracorpórea o similares: ejemplo ureteroscopía en los que están muy distales). - Si > 5 mm y ≤ 10 mm: observar, pero agregar tamsulosina u otro alfabloqueante. - Si ≤ 5 mm: observar (se eliminan espontáneamente en casi todos). La eliminación se confirma con la salida del cálculo (ej. orinar en un colador) y, si no se objetiva, mediante un nuevo pieloTAC. Si no se elimina en 2 - 4 semanas, se deriva para su remoción. Si es coraliforme muy grande o falla la LEC (se intenta hacerla 2 veces), se realiza la nefrolitectomía percutánea (que es mucho más invasiva).

Fuente: Urología, cuestionario 6.2, P5

4. Un paciente presenta un cólico renal, el que es manejado con analgesia. La radiografía muestra un cálculo radiopaco (cálcico) en el uréter izquierdo, por lo que se solicita un pieloTAC, que visualiza un cálculo de 15 mm de diámetro, en relación al tercio superior del uréter izquierdo. La conducta más adecuada para el manejo de este paciente es:

a. Observar evolución
b. Indicar citrato oral
c. Realizar litotripsia extracorpórea
d. Instalar un catéter doble J
e. Instalar una sonda Foley

Respuesta correcta: c. Realizar litotripsia extracorpórea

Explicación: Una vez resuelto el cólico renal (cuadro agudo de dolor y vómitos), es necesario eliminar el cálculo. - Si > 10 mm: derivar a urólogo para LEC (litotripsia extracorpórea o similares). Si está ubicado en una zona muy distal, se tiene que hacer ureteroscopía, para extraerlo. Si es coraliforme muy grande o falla la LEC (se intenta hacerla 2 veces), se realiza la nefrolitectomía percutánea (que es mucho más invasiva). - Si > 5 mm y ≤ 10 mm: observar, pero agregar tamsulosina u otro alfabloqueante. - Si ≤ 5 mm: observar (se eliminan espontáneamente). La eliminación se confirma con la salida del cálculo (ej. orinar en un colador) y, si no se objetiva, mediante un nuevo pieloTAC. Si no se elimina en 2 - 4 semanas, se deriva para su remoción. El catéter doble J se indica en las pionefrosis, asociadas a litiasis, de modo de drenar la vía urinaria.

Fuente: Urología, cuestionario 6.5, P8

5. Un paciente de 49 años consulta por dolor en la fosa iliaca derecha, asociada a hematuria. El urocultivo es negativo. Se realiza estudio radiológico, que demuestra la presencia de un cálculo renal derecho, coraliforme, de gran tamaño (ver radiografía). El tratamiento más adecuado para este paciente es:



a. Alcalinizar la orina con citrato
b. Alopurinol oral
c. Litotripsia extracorpórea
d. Antibióticos orales
e. Nefrolitotomía percutánea

Respuesta correcta: e. Nefrolitotomía percutánea

Explicación: La conducta más adecuada ante un cálculo coraliforme grande es la nefrolitotomía percutánea (ya está obsoleta la cirugía anatrófica). La litotripsia extracorpórea puede ser útil, pero en los cálculos tan grandes, como este, es difícil que tenga éxito. Como los cálculos coraliformes se asocian a infección crónica por Proteus, es importante identificar si está presente esta bacteria y erradicarla.

Fuente: Urología, cuestionario 6.5, P14

Hiperplasia prostática y uropatía obstructiva (6)

6. Un paciente de 60 años consulta por dificultad para orinar. Refiere que desde hace varios meses demora más en orinar y que debe apretar el abdomen para lograrlo. En ocasiones demora un tiempo en poder empezar a orinar y en el último tiempo tiene que levantarse varias veces en la noche a orinar. El diagnóstico más probable es:

a. Infección urinaria
b. Tuberculosis renal
c. Cáncer de próstata
d. Adenoma de próstata
e. Prostatitis crónica

Respuesta correcta: d. Adenoma de próstata

Explicación: Tiene una uropatía obstructiva clásica: con síntomas obstructivos (latencia, disuria de esfuerzo) y síntomas irritativos (nicturia). La causa más frecuente es la hiperplasia benigna de próstata, también conocida como adenoma prostático.

Fuente: Urología, cuestionario 6.1, P8

7. Usted recibe a un paciente diagnosticado de hiperplasia prostática benigna, que actualmente no recibe ningún tratamiento. Él le refiere que desea iniciar algún tratamiento médico, ya que por ahora no quiere someterse a ninguna intervención quirúrgica, por mínima que esta sea. ¿Qué indicación le daría?

a. Iniciar anticolinérgicos
b. Iniciar betabloqueantes
c. Iniciar antiandrogénicos
d. Iniciar alfabloqueantes
e. Iniciar ejercicios de Koegel y terapia conductual

Respuesta correcta: d. Iniciar alfabloqueantes

Explicación: Resumen tratamiento HPB: - En casos asintomáticos, no requiere tratamiento. - El tratamiento médico suele ser de primera línea: o Se prefieren los alfabloqueantes (ej. tamsulosina) por ser más eficaces. o Como alterantiva, están los inhibidores de la 5-alfa reductasa (ej. finasteride y dutasteride), en especial, si la próstata sigue aumentando de tamaño (previenen la progresión, pero tienen más efectos adversos, tales como disfunción eréctil). o Finalmente, sirven también los inhibidores de la fosfodiesterasa 5 (ej. sildenafil y vardenafil), por lo que son una opción aceptable en pacientes con disfunción eréctil. - El tratamiento quirúrgico se reserva para los casos que no responden o que tienen complicaciones (obstrucción urinaria, hematuria, ITU recurrente, litiasis vesical, IRC post renal, hidroureteronefrosis). Actualmente existen varias opciones y la tecnología ha avanzado, permitiendo intervenciones menos invasivas, incluso en próstatas muy grandes (ej. enucleación láser se puede usar a todo los tamaños): o Si próstata pequeña o mediana (<80 cc): tratamiento transuretral (resección eléctrica o láser, con distintas técnicas). o Si próstata grande (>80 cc): prostatectomía simple (abierta o laparoscópica), o bien, tratamiento con láser transuretral (enucleación láser). Tema aparte: - Los anticolinérgicos son el tratamiento de segunda línea de la incontinencia de urgencia (de última línea hay otros tratamientos, tales como la inyección de toxina botulínica, entre otros). Sí pueden servir en la HPB, en las que se desarrolla una vejiga inestable, secundaria a la obstrucción crónica.

Fuente: Urología, cuestionario 6.2, P2

8. Un paciente de 69 años presenta un cuadro de larga evolución compatible con una uropatía obstructiva baja. Consulta hoy en el servicio de urgencia, ya que no ha podido orinar desde hace 12 horas y presenta mucho dolor abdominal bajo. Al examen físico se constata un globo vesical. La conducta más adecuada es:

a. Instalar cistostomía suprapúbica
b. Administrar alfabloqueantes
c. Drenar con sonda Nelaton
d. Instalar sonda a Foley
e. Administrar anticolinérgicos

Respuesta correcta: d. Instalar sonda a Foley

Explicación: Tiene una retención urinaria aguda clásica: globo vesical, dolor e imposibilidad de orinar. Se trata con sonda Foley, hasta que se resuelva quirúrgicamente la causa (en este caso, la hiperplasia prostática), ya que más de la mitad recurren al poco tiempo. La cistostomía suprapúbica solo se indica cuando no es posible pasar la sonda Foley, o cuando está contraindicada, como en la sección uretral o cirugía prostática reciente. Algunas guías internacionales sugieren intentar remover la sonda Foley a las 2 semanas, incluso si no se ha operado aún, indicando alfa bloqueantes y educando sobre los síntomas de una nueva retención.

Fuente: Urología, cuestionario 6.3, P2

9. Un paciente de 35 años, con historia de promiscuidad sexual y antecedente de una uretritis, tratada con antibióticos, consulta por disuria de esfuerzo, asociada a disminución del chorro miccional y goteo terminal, de un mes de evolución, que ha empeorado en el último tiempo. Su examen físico, incluyendo un tacto rectal, es normal. El diagnóstico de sospecha es:

a. Hiperplasia benigna de la próstata
b. Prostatitis aguda
c. Cáncer de próstata
d. Estenosis uretral
e. Tuberculosis renal

Respuesta correcta: d. Estenosis uretral

Explicación: Tiene clínica de una uropatía obstructiva clásica, con síntomas obstructivos (disuria de esfuerzo, goteo y disminución del chorro). En este caso, por tener el antecedente de una uretritis, lo más probable es que sea una estenosis uretral (se estudia con uretrocistografía o con uretrocistoscopía). Otros antecedentes que sugieren estenosis uretral son RTU (resección transuretral) y trauma perineal, que son las dos primeras causas. El tratamiento se realiza con múltiples técnicas, pero, de primera línea se suelen usar procedimientos endoscópicos, mientras que los que fallan, suelen ir a una uretroplastía quirúrgica.

Fuente: Urología, cuestionario 6.4, P8

10. Un paciente de 80 años, se realiza una RTU (resección transuretral) por un adenoma de próstata, la que resulta exitosa, sin embargo, en la biopsia se aprecian zonas de adenocarcinoma de bajo grado. Su APE es normal, al igual que su tacto rectal y no tiene otras alteraciones en el examen físico. La conducta más adecuada es:

a. Realizar prostatectomía radical y quimioterapia
b. Solicitar APE libre
c. Solicitar biopsia prostática transrectal
d. Observar evolución, controlándolo periódicamente

e. Indicar hormonoterapia

Respuesta correcta: d. Observar evolución, controlándolo periódicamente

Explicación: Es una pregunta difícil, pero por tener un cáncer de próstata confirmado, que está localizado y además tiene más de 70 años (expectativa de vida menor a 10 años). Además, se trata de un cáncer de bajo riesgo, ya que tiene APE bajo y biopsia de bajo grado. Por tanto, se debe observar, ya que es un cáncer lento, que probablemente no alcanzará a causar grandes problemas, antes de que muera por otra razón. Como alternativa está la radioterapia local (braquiterapia) e incluso la prostatectomía radica, sin embargo, en este caso, la observación activa parece por lejos la opción más razonable. Si hubiese sido menor de 70 años y con un cáncer de riesgo moderado o alto, se preferiría la prostatectomía radical. Como alternativa también está la braquiterapia.

Fuente: Urología, cuestionario 6.5, P1

11. Un paciente de 65 años presenta disuria de esfuerzo y disminución del calibre del chorro miccional, asociado a nicturia y 3 episodios de infección urinaria, que han respondido al tratamiento antibiótico oral. Su tacto rectal es compatible con una hiperplasia prostática, sin nódulos y su APE es normal. Se solicita una ecografía prostática y vesical, que resulta compatible con un adenoma de 30 cc. La conducta más adecuada es:

a. Iniciar alfabloqueantes
b. Iniciar bloqueadores del receptor de testosterona
c. Derivar para resección transuretral
d. Derivar para cirugía abierta
e. Realizar biopsia prostática transrectal

Respuesta correcta: c. Derivar para resección transuretral

Explicación: Es una pregunta específica. Tiene una hiperplasia prostática benigna, con indicación de cirugía, dado que tiene infecciones urinarias recurrentes. Por tener un adenoma menor a 60 cc (80 cc según la guía norteamericana), de elección es la RTU (resección transuretral). Si fuera mayor a 60 cc (80 cc), se preferiría la cirugía abierta o un procedimiento láser (que no usa líquido hipotónico y, por tanto, no tiene riesgo de síndrome Post-RTU). - Si no hubiese tenido la ITU recurrente, se trataría con alfabloqueantes. - El screening de cáncer de próstata está negativo (tacto y APE normales), por lo que no se debe biopsiar. Eso sí, lo obtenido en la RTU sí se envía a biopsia rutinaria.

Fuente: Urología, cuestionario 6.5, P18

Cáncer de próstata y antígeno prostático (8)

12. Un paciente de 50 años se realiza por primera vez el screening para cáncer de próstata. El tacto rectal es normal y el antígeno prostático específico (APE) resulta 0,85 ng/ml. La conducta más adecuada es:

a. Solicitar APE libre
b. Solicitar ecografía prostática y vesical
c. Derivar a biopsia prostática transrectal
d. Realizar nuevo APE en 6 meses
e. Realizar nuevo APE y tacto rectal en un año

Respuesta correcta: e. Realizar nuevo APE y tacto rectal en un año

Explicación: Tiene un screening negativo, por lo que se debe controlar en un año. Si el screening hubiese sido positivo (tacto con nódulo o APE mayor a 4), estaría indicada la biopsia transrectal). Vale la pena

mencionar que, actualmente, las recomendaciones internacionales solo indican el APE como método de screening y no el tacto rectal.

Fuente: Urología, cuestionario 6.1, P2

13. El tratamiento más adecuado para un paciente con cáncer de próstata y presencia de metástasis óseas es:

a. Paliativo
b. Quimioterapia
c. Radioterapia externa.
d. Radioterapia de tipo braquiterapia (con implantación de semilla radiactiva)
e. Hormonoterapia

Respuesta correcta: e. Hormonoterapia

Explicación: El cáncer de próstata metastásico se trata con hormonoterapia, con agonistas de la GnRH (si no hay, se puede indicar flutamida) o incluso con castración quirúrgica, dado que es un cáncer muy hormonodependiente. Actualmente, además, existen múltiples fármacos modernos y específicos, incluyendo anticuerpos monoclonales, que se recomiendan ser usados en conjunto con la hormonoterapia, en la medida que haya recursos para ello, puesto que son caros. La braquiterapia se puede usar en el cáncer localizado.

Fuente: Urología, cuestionario 6.1, P17

14. Un paciente de 56 años se realiza un APE que resulta 5,1 ng/ml, con una fracción de APE libre de 9%. EL tacto rectal es normal. La conducta más adecuada es:

a. Repetir APE y TR en 1 año
b. Repetir APE y TR en 6 meses
c. Solicitar biopsia prostática transrectal
d. Solicitar ecografía vesicoprostática
e. Iniciar finasteride

Respuesta correcta: c. Solicitar biopsia prostática transrectal

Explicación: Tiene un screening de cáncer de próstata positivo (por el APE mayor a 4,0 ng/ml). Por tanto, se debe proceder a la biopsia prostática, por vía transrectal, idealmente guiada por ecografía. El APE libre no es un buen indicador, pero en general, si es menor a 15%, hay mayor riesgo de que se trate de un cáncer y el riesgo aumenta, a medida que baja el APE libre. Muchas guías internacionales solo recomiendan el APE y no el tacto rectal como screening.

Fuente: Urología, cuestionario 6.2, P6

15. Un paciente de 60 años, asintomático, se realiza un control rutinario, en el que se pesquisa antígeno prostático específico de 1,5 ng/ml y un tacto rectal con un nódulo prostático duro de cerca de un cm de diámetro, localizado en el lóbulo derecho. La conducta más adecuada es:

a. Observar evolución
b. Solicitar APE libre
c. Solicitar biopsia prostática
d. Realizar prostatectomía radical
e. Iniciar bloqueantes del receptor de testosterona

Respuesta correcta: c. Solicitar biopsia prostática

Explicación: Tiene un screening positivo (nódulo en el tacto rectal), por lo que se debe biopsiar. Si bien el APE está normal (menor a 4), se debe recordar que las indicaciones de biopsia son 3: I. TR positivo, II. APE mayor a 4 y III. Velocidad de APE mayor a 0,75 ng/ml. Aunque recomendaciones internacionales actuales recomiendan no realizar el TR como screening, el hecho de haberlo realizado y que estuviera alterado obliga a biopsiarlo.

Fuente: Urología, cuestionario 6.3, P4

16. Un paciente de 52 años se realiza un tacto rectal que resulta normal y un APE que resulta 3,1 ng/ml. Está asintomático, sin embargo, su control anterior mostraba un APE de 2,0 ng/dl. La conducta más adecuada es:

a. Repetir el APE
b. Controlar con nuevo APE y tacto rectal en un año
c. Solicitar biopsia prostática transrectal
d. Solicitar APE libre
e. Iniciar un inhibidor de la 5-alfa reductasa

Respuesta correcta: c. Solicitar biopsia prostática transrectal

Explicación: Tiene un screening de cáncer de próstata positivo (velocidad de APE mayor a 0,75, ya que 3,1 – 2, 0 = 1,1. Por tanto, se debe biopsiar. Si bien la velocidad de APE no es un buen indicador, las recomendaciones el Minsal indican que se debe biopsiar (también en APE mayor a 4 y en tacto rectal alterado). Las recomendaciones internacionales indican solo utilizar el APE con el valor de corte de 4 ng/ml y nada más. La velocidad de APE solo la aceptan en pacientes que usan inhibidores de la 5 alfa reductasa (ej. finasteride), en las que el APE solo puede tener una menor sensibilidad.

Fuente: Urología, cuestionario 6.4, P1

17. ¿Cuál de las siguientes opciones corresponde a una complicación frecuente de la prostatectomía radical?

a. Edema cerebral
b. Estenosis uretral
c. Aneyaculación
d. Eyaculación retrógrada
e. Impotencia sexual

Respuesta correcta: e. Impotencia sexual

Explicación: La prostatectomía radical suele afectar el plexo parasimpático pudendo, encargado de la erección, por lo que muy frecuentemente evoluciona con impotencia sexual. - El edema cerebral es complicación de las RTU de larga duración, dado que utilizan líquidos hipo osmolares, que se absorben durante el procedimiento. Por ello es que no se puede utilizar en próstatas muy grandes (punto de corte es 80 ml de volumen prostático). Afortunadamente, en la actualidad existe la enucleación láser, que se realiza por vía transuretral y puede ser aplicada en pacientes con próstatas grandes también. - La estenosis uretral es complicación de la RTU, aunque también se puede ver en otras cirugías prostáticas y uretrales. - La aneyaculación es complicación de la LALA (linfadenectomía lumboaórtica), ya que daña los plexos simpáticos del retroperitoneo, encargados de la eyaculación. - La eyaculación retrógrada es complicación de la RTU prostática y de la cirugía abierta del adenoma de próstata.

Fuente: Urología, cuestionario 6.4, P4

18. Un paciente de 60 años se realiza un tacto rectal, que resulta normal y se toma niveles de antígeno prostático específico, que resulta 6,0 ng/ml. La conducta más adecuada es:

a. Solicitar APE libre
b. Solicitar nuevo APE en 6 meses
c. Realizar nuevo APE y tacto rectal en un año
d. Realizar biopsia prostática transrectal
e. Realizar resección transuretral

Respuesta correcta: d. Realizar biopsia prostática transrectal

Explicación: Tiene un screening de cáncer de próstata positivo (por el APE mayor a 4,0 ng/ml). Por tanto, se debe proceder a la biopsia prostática, por vía transrectal, idealmente guiada por ecografía. La biopsia se indica también si la velocidad de APE es mayor a 0,75 o si el tacto rectal muestra nódulos prostáticos. El APE libre no es un buen indicador, pero en general, si es menor a 15%, hay mayor riesgo de que se trate de un cáncer y el riesgo aumenta, a medida que baja el APE libre. Recomendaciones actuales sugieren usar solo el APE total como screening de cáncer de próstata.

Fuente: Urología, cuestionario 6.5, P7

19. ¿Cuál de las siguientes opciones es más útil para definir el pronóstico en un paciente con cáncer de próstata?

a. Niveles plasmáticos de APE
b. Porcentaje de APE libre
c. Edad
d. TAC de abdomen y pelvis
e. Ecografía prostática y vesical

Respuesta correcta: a. Niveles plasmáticos de APE

Explicación: El pronóstico del cáncer de próstata se base en 3 elementos: 1. Niveles plasmáticos de APE, 2. Extensión en el tacto rectal y 3. Grado de diferenciación histológica (score de Gleasson). De las 3 cosas, la más importante son los niveles de APE, al punto que si el APE está bajo 20 ng/ml y el paciente no tiene dolores óseos, se asume que no tiene metástasis. Si en cambio está mayor a 20 ng/dl o tiene dolores óseos, se debe pedir una cintigrafía ósea, para descartar las metástasis.

Fuente: Urología, cuestionario 6.5, P13

Tumores renales y de la vía urinaria (10)

20. Una paciente de 60 años consulta por hematuria de 2 semanas de evolución. Su examen físico es normal, por lo que se solicita un sedimento de orina, que resulta normal; un urocultivo, que resulta negativo y una ecografía renal y vesical, que resulta también normal. El estudio debe proseguir con:

a. Baciloscopía de orina
b. Resonancia magnética nuclear
c. Cintigrafía
d. Tomografía axial computada
e. Cistoscopía

Respuesta correcta: e. Cistoscopía

Explicación: El estudio de la hematuria sigue un orden: 1. Sedimento de orina y urocultivo (descarta ITU y las glomerulonefritis), 2. Ecografía renal y vesical (o uroTAC si la sospecha es un cáncer) y 3. Cistoscopía (que permite descartar el cáncer de vejiga).

Fuente: Urología, cuestionario 6.1, P5

21. Un paciente de 65 años se realiza una ecografía abdominal, como parte del estudio de un cólico biliar, que además de confirmar la presencia de colelitiasis, detecta un tumor renal de 5 cm de diámetro, en relación al polo superior del riñón derecho, de aspecto sólido. La conducta más adecuada es:

a. Solicitar un TAC de abdomen y pelvis con contraste
b. Solicitar una resonancia magnética nuclear
c. Solicitar un PieloTAC
d. Realizar radioterapia y quimioterapia combinadas
e. Resolver quirúrgicamente con nefrectomía parcial

Respuesta correcta: a. Solicitar un TAC de abdomen y pelvis con contraste

Explicación: Si bien el tratamiento del cáncer renal menor a 7 cm y limitado al riñón consiste en la nefrectomía parcial (no responde bien ni a la radioterapia ni a la quimioterapia), primero es necesario realizar una TAC con contraste, de modo de determinar la presencia de metástasis, que podrían cambiar el tratamiento (ej. tratamiento paliativo o nefrectomía más linfadenectomía). El pieloTAC es una TAC sin contraste que se usa en el estudio de la litiasis renal.

Fuente: Urología, cuestionario 6.1, P6

22. Un paciente se realiza un TAC de abdomen y pelvis, visualizándose un tumor renal de 8 cm de diámetro, sin adenopatías retroperitoneales. La conducta más adecuada es:

a. Realizar nefrectomía radical
b. Realizar nefrectomía parcial
c. Realizar radioterapia + quimioterapia
d. Realizar nefrectomía radical + radioterapia + quimioterapia
e. Solicitar PET-scan

Respuesta correcta: a. Realizar nefrectomía radical

Explicación: Los tumores renales sólidos generalmente son cáncer, por lo que se tratan directamente, con cirugía, ya que no responden a la quimioterapia ni a la radioterapia. La cirugía depende del tamaño y ubicación: - Si es menor a 4 cm se tratan con nefrectomía parcial (es aceptable la ablación como técnica menos cruenta). - Si es tiene entre 4 y 7 (algunos aguantan hasta 10 cm) también se tratan con nefrectomía parcial, en la medida que sea posible. - Si es mayor a 7 cm, está localizado en el hilio renal o invade la vena renal o la glándula suprarrenal, pues se tratan con nefrectomía radical más linfadenectomía.

Fuente: Urología, cuestionario 6.2, P1

23. Una mujer de 68 años, presenta hematuria recurrente. Su examen físico es normal, el sedimento de orina demuestra hematuria no glomerular de más de 100 GR por campo y el urocultivo es negativo. Se solicita ecografía renal y vesical que no muestra alteraciones. La sospecha diagnóstica es:

a. Cistitis intersticial
b. Tuberculosis renal
c. Cáncer de vejiga

d. Cáncer de pelvis uretral
e. Urolitiasis

Respuesta correcta: c. Cáncer de vejiga

Explicación: La causa más frecuente de hematuria monosintomática en el adulto es el cáncer de vejiga. Más aún, si ya se descartó la ITU y tiene una ecografía normal. De hecho, se debe proceder a la cistoscopía o a una urografía por TAC (uroTAC).

Fuente: Urología, cuestionario 6.3, P5

24. Un paciente de 63 años, monorreno de nacimiento, se detecta un tumor renal izquierdo de 3 cm de diámetro, de aspecto sólido en la ecografía, ubicado en el polo superior del riñón. El TAC de abdomen y pelvis no visualiza adenopatías. La conducta es:

a. Observar evolución
b. Realizar nefrectomía parcial
c. Realizar nefrectomía radical
d. Realizar nefrectomía parcial más radioterapia postoperatoria
e. Realizar nefrectomía radical más radioterapia y quimioterapia postoperatorias

Respuesta correcta: b. Realizar nefrectomía parcial

Explicación: Los tumores renales sólidos generalmente son cáncer, por lo que se tratan directamente, con cirugía, ya que no responden a la quimioterapia ni a la radioterapia. La cirugía depende del tamaño y ubicación: - Si es menor a 4 cm se trata con nefrectomía parcial o tumorectomía, siendo incluso aceptable la ablación. En menores de 1 cm, es más, se puede incluso observar y controlar periódicamente. - Si es menor a 7-10 cm también se tratan con nefrectomía parcial o tumorectomía, en la medida que sea técnicamente posible. - Si es mayor a 7-10 cm o es técnicamente imposible por está localizado en el hilio renal, invadir la vena renal o la glándula suprarrenal, se tratan con nefrectomía radical más linfadenectomía.

Fuente: Urología, cuestionario 6.3, P6

25. Una mujer de 40 años, sin antecedentes de importancia, asintomática, se realiza exámenes generales, como parte de un chequeo médico, en los que destaca sedimento de orina con 4 eritrocitos por campo, 8 leucocitos por campo, bacterias escasas, sin cilindros y un urocultivo que muestra desarrollo de E. coli multisensible, con 20.000 UFC por ml. La conducta más adecuada es:

a. Observar evolución
b. Indicar ciprofloxacino oral por 3 días
c. Indicar nitrofurantoína oral por 7 días
d. Indicar cefadroxilo oral por 1 vez
e. Indicar ceftriaxona endovenosa por 1 vez

Respuesta correcta: a. Observar evolución

Explicación: En primero lugar, el urocultivo está negativo, ya que, en la orina de segundo chorro, se exige un recuento mayor a 100.000 UFC/mm3, para hacer el diagnóstico de ITU. En segundo lugar, si tuviera un urocultivo positivo, por el hecho de estar asintomática, sería una bacteriuria asintomática, que no requiere tratamiento. Finalmente, nunca debió haberse pedido el urocultivo a alguien asintomática, a menos que esté embarazada.

Fuente: Urología, cuestionario 6.4, P9

26. El tratamiento de los tumores de pelvis renal es:

a. Nefrectomía parcial
b. Nefrectomía radical
c. Nefroureterectomía
d. Quimioterapia + radioterapia
e. Resección transuretral + instilaciones con BCG

Respuesta correcta: c. Nefroureterectomía

Explicación: Los tumores de pelvis renal suelen ser de epitelio de transición (urotelio), por lo que es frecuente que se "siembren" en la vía urinaria. Por ello, no basta con resecar la pelvis renal (con el respectivo riñón), sino que, además, se debe resecar el uréter e, incluso, se reseca una parte de la vejiga (en otras palabras: nefroureterectomía). - Las nefrectomías parcial y radical son el tratamiento del cáncer renal localizado, mayor y menor a 7-10 cm, respectivamente. - La RTU + BCG es el tratamiento del cáncer de vejiga que no invade el detrusor. * BCG (bacilo de Calmette-Guérin) es el mismo de la vacuna contra la tuberculosis, que es una forma atenuada del Mycobacterium bovis.

Fuente: Urología, cuestionario 6.4, P10

27. Una paciente de 68 años es diagnosticada de cáncer de vejiga, mediante cistoscopía, que visualiza un tumor de aspecto velloso de 2 cm de diámetro. La biopsia muestra un carcinoma urotelial, que invade el músculo detrusor. El estudio de diseminación resulta negativo. El tratamiento más adecuado es:

a. Resección transuretral
b. Instilaciones con BCG
c. Cistectomía radical
d. Radioterapia
e. Resección transuretral más instilaciones con BCG

Respuesta correcta: c. Cistectomía radical

Explicación: Como invade el detrusor (T2), se debe tratar con cistectomía radical. Si no invadiera el detrusor (T1), el tratamiento sería la RTU + BCG (opción E).

Fuente: Urología, cuestionario 6.5, P3

28. Un paciente de 56 años presenta hematuria, por lo que se realiza una ecografía renal y vesical, que demuestra la presencia de un tumor renal izquierdo de 9 cm de diámetro, ubicado cerca del hilio renal. El TAC de abdomen y pelvis descarta la presencia de adenopatías y la invasión vascular. La conducta más adecuada es:

a. Realizar nefrectomía parcial
b. Realizar nefrectomía radical
c. Iniciar quimioterapia más radioterapia combinadas
d. Iniciar radioterapia y posteriormente realizar cirugía
e. Iniciar quimioterapia y posteriormente realizar cirugía

Respuesta correcta: b. Realizar nefrectomía radical

Explicación: Los tumores renales sólidos generalmente son cáncer, por lo que se tratan directamente, con cirugía, ya que no responden a la quimioterapia ni a la radioterapia. La cirugía depende del tamaño y ubicación: - Si es menor a 7 cm (algunos toleran hasta 10 cm) se tratan con nefrectomía parcial o tumorectomía. - Si es mayor a 7 cm (como en este caso) o está localizado en el hilio renal (también en este

caso), o bien invade la vena renal o la glándula suprarrenal, se tratan con nefrectomía radical más linfadenectomía. - Si estuviera metastizado, se trataría con inmunoterapia o fármacos antineoplásicos específicos (aumenta brevemente la sobrevida y es cara; la ley Ricarte Soto ofrece algunos de estos fármacos de alto costo a ciertos pacientes) más manejo paliativo.

Fuente: Urología, cuestionario 6.5, P6

29. Un paciente de 68 años presenta hematuria. Se solicita una ecografía y un TAC que muestran un tumor de pelvis renal, de 6 cm de diámetro, que infiltra el riñón. La conducta más adecuada es:

a. Realizar nefroureterectomía
b. Realizar nefrectomía parcial
c. Realizar nefrectomía radical
d. Iniciar quimioterapia y radioterapia combinadas
e. Realizar resección transuretral e instilaciones con BCG

Respuesta correcta: a. Realizar nefroureterectomía

Explicación: Los tumores de pelvis renal suelen ser de epitelio de transición (urotelio), por lo que es frecuente que se "siembren" en la vía urinaria. Por ello, no basta con resecar la pelvis renal (con el respectivo riñón), sino que, además, se debe resecar el uréter. En los tumores del pelvis renal, no importa el tamaño. Las nefrectomías parcial y radical son el tratamiento del cáncer renal localizado, mayor y menor a 7 cm, respectivamente. La RTU + BCG es el tratamiento del cáncer de vejiga que no invade el detrusor.

Fuente: Urología, cuestionario 6.5, P16

Patología escrotal y testicular (16)

30. Un paciente de 23 años se palpa un aumento de volumen, en relación al testículo derecho. Al examen físico se constata aumento de volumen en una zona del testículo, de cerca de 5 cm de diámetro y consistencia aumentada. La conducta más adecuada es:

a. Observar evolución
b. Solicitar biopsia por punción
c. Solicitar alfafetoproteína y HCG plasmáticas
d. Solicitar ecografía testicular
e. Derivar a orquiectomía radical

Respuesta correcta: d. Solicitar ecografía testicular

Explicación: El estudio del tumor testicular se inicia con la ecografía testicular. Si demuestra un tumor sólido, se procede a la orquiectomía radical y biopsia (la biopsia mínima de un testículo es el testículo completo). Los marcadores tumorales (alfafetoproteína y HCG) se piden solo si hay un tumor sólido en la ecografía y no cambian conducta, ya que la orquiectomía radical debe hacerse de todas formas. Si la ecografía muestra un tumor quístico, simplemente se observa evolución. La TAC de abdomen y pelvis suele pedirse para etapificar e, incluso, se puede pedir antes de la orquiectomía radical, pero es la ecografía la que determina la necesidad de la cirugía.

Fuente: Urología, cuestionario 6.1, P1

31. Un paciente consulta por disnea. La radiografía muestra múltiples metástasis pulmonares. En el examen físico, además se constata la presencia de un tumor primario testicular de gran tamaño, el que es

manejado quirúrgicamente. La biopsia demuestra que se trata de un seminoma puro y los marcadores tumorales son negativos. ¿Qué tratamiento es más adecuado para este paciente?

a. Radioterapia
b. Linfadenectomía lumboaórtica
c. Quimioterapia
d. Hormonoterapia
e. Manejo paliativo

Respuesta correcta: c. Quimioterapia

Explicación: Por regla general, el tratamiento del cáncer de testículo con metástasis es la quimioterapia, ya que suele ser un cáncer muy quimiosensible (excepto el teratoma maligno, que no responde ni a QT ni a RT, por lo que se trata con cirugía incluso de las metástasis). - En cambio, si está limitado al testículo (sin metástasis), existen varias opciones de manejo: observación, quimioterapia, radioterapia y linfadenectomía lumboaórtica. - Seminoma: 1. Observar es lo más recomendado; son aceptables 2. QT o 3. RT. - No seminoma de bajo riesgo: 1. Observar o 2. QT. - No seminoma de alto riesgo: 1. QT o LALA son aceptables. - La hormonoterapia es el tratamiento del cáncer de próstata avanzado, aunque actualmente existen múltiples otros fármacos complementarios y específicos, que se recomiendan usar en conjunto con la hormonoterapia.

Fuente: Urología, cuestionario 6.1, P7

32. Un paciente de 25 años consulta por aumento de volumen escrotal. Al examen físico se aprecia aumento de volumen escrotal izquierdo, de consistencia blanda, sin afectación del testículo, el que se palpa normal. El aumento de volumen aumenta al realizar maniobras de Valsalva y se solicita una ecografía testicular que confirma la presencia de un varicocele de tamaño moderado. La conducta más adecuada es:

a. Realizar ligadura de los plexos pampiniformes
b. Solicitar marcadores tumorales
c. Observar evolución
d. Solicitar ecografía renal y vesical
e. Solicitar TAC de abdomen y pelvis

Respuesta correcta: c. Observar evolución

Explicación: El tratamiento de elección del varicocele asintomático es simplemente la observación. La ligadura se indica en los casos en que es gigante, se asocia a dolor crónico, atrofia testicular o afectación de la fertilidad (en alguien con deseos de fertilidad).

Fuente: Urología, cuestionario 6.1, P12

33. Un niño de 10 años consulta por dolor testicular muy intenso, que inició hace 30 minutos. El testículo se palpa aumentado de tamaño y está algo ascendido. La conducta más adecuada es:

a. Iniciar tratamiento con analgésicos y antibióticos orales
b. Solicitar pieloTAC
c. Realizar exploración quirúrgica, de inmediato
d. Solicitar ecografía doppler y decidir conducta según hallazgos
e. Indicar corticoides endovenosos

Respuesta correcta: c. Realizar exploración quirúrgica, de inmediato

Explicación: Tiene un testículo agudo clínico, por lo que es mandatorio explorar quirúrgicamente, por el riesgo de que se trate de una torsión testicular (también puede ser torsión de la hidátide, pero la exploración quirúrgica es quien hará la diferencia). El ecodoppler solo es de utilidad en los casos clínicamente dudosos, en los que hay una baja probabilidad de que exista una torsión (ej. dolor desde hace 24 horas), ya que, de lo contrario, no se debe retrasar la exploración quirúrgica.

Fuente: Urología, cuestionario 6.1, P18

34. Un niño de 18 meses de edad, sin controles médicos previos, presenta ausencia del testículo derecho, sin otras alteraciones en su examen físico. Se solicita ecografía inguinoescrotal, que es capaz de detectar el testículo, en relación al conducto inguinal, en el tercio medio de este. La conducta más adecuada es:

a. Observar evolución
b. Iniciar testosterona
c. Iniciar gonadotropina coriónica humama
d. Resolver quirúrgicamente
e. Solicitar cariograma

Respuesta correcta: d. Resolver quirúrgicamente

Explicación: El tratamiento de la criptorquídea es la cirugía de descenso testicular, más orquidopexia. Si tiene menos de 1 año, se puede observar, ya que probablemente descenderá espontáneamente (generalmente desciende antes de los 4 meses). Si tiene más de un año, ya se debe operar (algunos recomiendan hacerlo antes). Por regla general, se exige operarlo siempre antes de que cumpla 2 años, ya que desde esa edad se dispara el riesgo de atrofia e infertilidad. Vale la pena recordar, que, a pesar de operarse, mantendrá un riesgo mayor de desarrollar cáncer de testículo. RESUMEN CRIPTORQUÍDEA: - El diagnóstico de cirptorquídea se realiza con el solo examen físico. Puede ser palpable (ej. se palpa en la zona inguinal) o no palpable. - Si es palpable y no se puede descender, se confirma el diagnóstico. Para diferenciar entre un testículo no descendido (se queda en el conducto inguinal o en la cavidad abdominal) de un testículo ectópico, se suele ver la ubicación (el ectópico pasa por todo el conducto inguinal, pero se aloja en un lugar errado: saco suprapúbico, periné, compartimento escrotal contralateral, por ejemplo). - Si es posible descender el testículo palpado al escroto, pues no se es una criptorquídea, sino que es un testículo retráctil, que es una condición normal, que simplemente se sigue con control anual. - Si no es palpable, probablemente también se trata de un testículo no descendido, aunque puede ser también una agenesia testicular. La ecografía puede ser de ayuda, pero tiene muy mal rendimiento, en comparación con la exploración quirúrgica, por lo que esta última es el gold standard como procedimiento diagnóstico y es lo más importante. - El momento de la cirugía suele ser a los 12 meses, pero, en vista de que es raro el descenso espontáneo después de los 4 meses y que, además, la fertilidad se puede afectar más temprano de lo que se creía, actualmente se recomienda que la cirugía se realice incluso desde los 4 meses en adelante. - Si es bilateral o si se asocia a hipospadia, se debe realizar cariograma, para descartar alteraciones congénitas del desarrollo sexual.

Fuente: Urología, cuestionario 6.1, P19

35. Un paciente de 30 años nota un tumor testicular, el que se confirma con la ecografía, viéndose como un tumor sólido de 3 cm de diámetro, en relación al testículo derecho. La conducta más adecuada es:

a. Programar cirugía radical y solicitar marcadores tumorales
b. Solicitar TAC de abdomen y pelvis
c. Realizar punción biópsica
d. Solicitar marcadores tumorales y decidir conducta según resultados

e. Iniciar quimioterapia

Respuesta correcta: a. Programar cirugía radical y solicitar marcadores tumorales

Explicación: El estudio del tumor testicular se inicia con la ecografía testicular. Si la ecografía muestra un tumor quístico, simplemente se observa la evolución (no es cáncer). Si demuestra un tumor sólido, se procede a la orquiectomía radical y biopsia (la biopsia mínima de un testículo es el testículo completo). Los marcadores tumorales (alfafetoproteína y HCG) se piden solo si hay un tumor sólido en la ecografía y no cambian conducta, ya que la orquiectomía radical debe hacerse de todas formas (en un tumor sólido). La TAC de abdomen y pelvis sí se suele pedir como examen de etapificación, pero la necesidad de cirugía queda determinada por la ecografía.

Fuente: Urología, cuestionario 6.2, P3

36. Un paciente de 75 años consulta por aumento de volumen escrotal, indoloro. Al examen físico se aprecia escroto distendido, pudiéndose palpar el testículo, el que no presenta alteraciones evidentes. El diagnóstico más probable es:

a. Varicocele
b. Orquitis
c. Epididimitis
d. Cáncer testicular no seminoma
e. Hidrocele

Respuesta correcta: e. Hidrocele

Explicación: Solo tiene aumento de volumen escrotal, no testicular. En adultos mayores, la causa más frecuente de esto es el hidrocele (acumulación de líquido en la túnica vaginal), que se diagnostica con la prueba de trasiluminación. El varicocele se palpa como una “bolsa de gusanos” y sería también una respuesta aceptable. La orquitis y epididimitis tienen dolor y fiebre. El cáncer tendría afectación del testículo mismo.

Fuente: Urología, cuestionario 6.2, P8

37. Un paciente se realiza una orquiectomía radical, luego de haberse detectado un tumor testicular izquierdo de 3 cm. La biopsia es informada como seminoma, los marcadores tumorales prequirúrgicos muestran marcada elevación, tanto de la alfafetoproteína, como de la HCG. Luego de la cirugía, los marcadores disminuyen marcadamente, pero se mantienen sobre el valor normal. La TAC de abdomen y pelvis no observa adenopatías sospechosas. La conducta más adecuada es:

a. Realizar radioterapia retroperitoneal
b. Realizar linfadenectomía lumboaórtica o quimioterapia
c. Solicitar resonancia magnética nuclear de abdomen y pelvis
d. Iniciar hormonoterapia con inhibidores de la 5 alfareductasa
e. Iniciar hormonoterapia con agonistas de la GnRH

Respuesta correcta: b. Realizar linfadenectomía lumboaórtica o quimioterapia

Explicación: Que la alfafetoproteína esté muy elevada sugiere que realmente no es un seminoma puro, sino que tiene un componente de no seminoma, por lo que debe ser manejado como un no seminoma. El tratamiento del cáncer de testículo ha cambiado en el último tiempo y se puede resumir de la siguiente forma: - Localizados: o Seminoma: 1. Observar es lo más recomendado; son aceptables 2. QT o 3. RT. o No seminoma de bajo riesgo: 1. Observar o 2. QT. o No seminoma de alto riesgo: 1. QT o LALA son aceptables.

- Avanzado: QT (excepto teratoma maligno que solo responde a cirugía). Con todo, es una pregunta muy discutible, con más de una respuesta correcta y que actualmente es de manejo del especialista.

Fuente: Urología, cuestionario 6.3, P1

38. Usted evalúa a un recién nacido constatándose ausencia del testículo derecho en el escroto. La ecografía inguinoescrotal lo muestra en el tercio distal del conducto inguinal. La conducta es:

a. Realizar cirugía de descenso de inmediato
b. Realizar extirpación quirúrgica de inmediato
c. Solicitar cariograma
d. Iniciar testosterona
e. Observar evolución en espera del descenso espontáneo

Respuesta correcta: e. Observar evolución en espera del descenso espontáneo

Explicación: Tiene una criptorquídea, la que se puede observar hasta el año de edad, ya que es frecuente que haya descenso espontáneo. Sin embargo dicho descenso suele ocurrir antes de los 4 meses, por lo que hay quienes recomiendan operar antes del año de edad (ej. desde los 6 o incluso 4 meses). Luego de año (e idealmente antes de los 2 años), se debe operar, con cirugía de descenso y pexia testicular.

Fuente: Urología, cuestionario 6.3, P7

39. Un paciente de 25 años presenta aumento de volumen del testículo izquierdo. Al examen físico se palpa un tumo testicular, de cerca de 5 cm. No presenta dolor ni otros síntomas. La conducta más adecuada es:

a. Solicitar biopsia por punción
b. Realizar tumorectomía y biopsia
c. Solicitar ecografía testicular
d. Realizar orquiectomía radical
e. Solicitar alfafetoproteína y HCG y decidir conducta según resultados

Respuesta correcta: c. Solicitar ecografía testicular

Explicación: El examen inicial del estudio del tumor testicular es la ecografía testiculoescrotal. Si tiene un tumor sólido, se procede a la orquiectomía radical (con posterior biopsia) y se solicitan los marcadores tumorales.

Fuente: Urología, cuestionario 6.4, P5

40. Un paciente de 18 años presenta dolor testicular izquierdo, muy intenso, que inició súbitamente hace 30 minutos. Ha presentado vómitos en dos oportunidades y al examen físico se constata testículo izquierdo doloroso y aumentado de volumen. El diagnóstico más probable es:

a. Orquiepididimitis
b. Cólico renal
c. Torsión testicular
d. Trombosis de la vena renal
e. Varicocele

Respuesta correcta: c. Torsión testicular

Explicación: Tiene un cuadro clásico de testículo agudo: dolor de inicio súbito, asociado a aumento de volumen y en ocasiones ascenso testicular. La causa más frecuente en adolescentes y adultos es la torsión testicular. Se debe proceder a la exploración quirúrgica inmediata. No realizarla o demorar su realización

en estudios o trámites administrativos es considerado una negligencia médica. - En niños puede ser una torsión de la hidátide (en especial si tiene una zona azul en el escroto). Sin embargo, igual se debe explorar quirúrgicamente de inmediato, ya que no se puede arriesgar a perder un testículo si es una torsión testicular. - La trombosis de la vena renal es una complicación del síndrome nefrótico, que produce dolor lumbar (similar a cólico renal), más hematuria y falla renal (más varicocele, si afecta el lado izquierdo).

Fuente: Urología, cuestionario 6.4, P6

41. Un lactante de 2 meses de edad presenta escroto con solo un testículo: el derecho. Se solicita ecografía inguinoescrotal, que no visualiza el testículo faltante. La conducta más adecuada es:

a. Solicitar cintigrafía
b. Solicitar alfafetoproteína y HCG plasmáticas
c. Realizar laparoscopía exploradora en unos meses
d. Solicitar cariograma
e. Observar evolución

Respuesta correcta: c. Realizar laparoscopía exploradora en unos meses

Explicación: El estudio de un testículo ausente no tiene una única forma de realizarse, pero lo más habitual es que se inicie con una ecografía inguinoescrotal (que encuentra el 70% de las criptorquídeas), aunque no es obligatorio realizar imágenes. La laparoscopía exploradora (en busca de un testículo intra-abdominal) el el gold standard para identificar y reparar la criptorquídea. El momento de la cirugía suele ser a los 12 meses, pero, en vista de que es raro el descenso espontáneo después de los 4 meses y que, además, la fertilidad se puede afectar más temprano de lo que se creía, actualmente se recomienda que la cirugía se realice incluso desde los 4 meses en adelante; más aún si el testículo no está en el conducto inguinal. Los testículos intrabdominales, en algunos casos son imposibles de descender en una sola intervención y se realiza una cirugía en dos tiempos, que se llama técnica de Fowler-Stephens. Eso sí, algunos sí pueden descenderse en un solo tiempo. Si es bilateral o si se asocia a hipospadia, se debe realizar cariograma, para descartar alteraciones congénitas del desarrollo sexual.

Fuente: Urología, cuestionario 6.4, P7

42. Un paciente de 30 años es diagnosticado de un teratoma maligno, mediante una biopsia excisional de testículo. Además, se cuenta con una alfafetoproteína y gonadotrofina coriónica humana, las que resultan elevadas. Se solicita un TAC de abdomen y pelvis, que no visualiza adenopatías sospechosas. La conducta más adecuada es:

a. Iniciar radioterapia
b. Iniciar hormonoterapia
c. Iniciar quimioterapia
d. Observar evolución
e. Realizar linfadenectomía lumboaórtica

Respuesta correcta: e. Realizar linfadenectomía lumboaórtica

Explicación: El manejo actual del cáncer testicular se puede resumir de la siguiente forma: - Seminoma localizado: 1. Observar (es lo más recomendado); son aceptables 2. QT o 3. RT. - Seminoma con mestástasis: QT. - No seminoma localizado de bajo riesgo: 1. Observar o 2. QT. - No seminoma localizado de alto riesgo: 1. QT o LALA son aceptables (excepto en teratoma maligno en que siempre se elige LALA). - No seminoma avanzado: QT (excepto teratoma maligno que solo responde a cirugía).

Fuente: Urología, cuestionario 6.5, P2

43. Un recién nacido presenta ausencia del testículo derecho en el examen físico. Al examinarlo más acuciosamente, se palpa en la zona inguinal, en relación al tercio medio del conducto inguinal, sin embargo, no es posible descenderlo al escroto. Se solicita una ecografía inguinal, que confirma la presencia del testículo en el conducto inguinal. La conducta más adecuada es:

a. Observar evolución
b. Realizar resección quirúrgica del testículo afectado
c. Realizar cirugía de descenso testicular y orquidopexia, de inmediato
d. Solicitar cariograma
e. Iniciar testosterona

Respuesta correcta: a. Observar evolución

Explicación: Tiene una criptorquídea clínica y confirmada con ecografía, la que se puede observar hasta los 4 a 12 meses de edad, ya que es frecuente que haya descenso espontáneo (en particular antes de los 4 meses). Si no se produce el descenso, se debe realizar la cirugía de descenso más orquidopexia (desde los 4 meses ya es posible, pero hay quienes operan a que cumpla un año). Como dato adicional, la cirugía de descenso suele ser por vía inguinal, cuando el testículo es palpable, en cambio, es por vía laparoscópica cuando no es palpable. Si hubiese sido posible descenderlo, sería un testículo en retráctil o en ascensor, que se observa, por ser algo normal.

Fuente: Urología, cuestionario 6.5, P5

44. Un paciente de 15 años consulta por dolor testicular izquierdo intenso, que inició hace una hora y que se ha asociado a vómitos. Al examen físico se aprecia aumento de volumen del testículo izquierdo, el que es muy doloroso a la palpación. El diagnóstico más probable es:

a. Orquiepididimitis
b. Varicocele complicado
c. Cólico renal
d. Dolor testicular idiopático benigno
e. Torsión testicular

Respuesta correcta: e. Torsión testicular

Explicación: Tiene un testículo agudo clásico (dolor de inicio agudo, con aumento de volumen y síntomas disautonómicos: vómitos), cuya causa más frecuente es la torsión testicular, en especial en adolescentes y adultos (en niños es más frecuente la torsión de la hidátide de Morganini, que se caracteriza, además, por el "punto azul" en el escroto). La orquiepididimitis tiene dolor subagudo, con eritema y fiebre. El cólico renal tiene dolor lumbar (que puede irradiarse a los genitales, así como el dolor testicular puede irradiarse a la zona lumbar), más agitación psicomotora y vómitos. El dolor testicular idiopático benigno produce dolor testicular crónico, recurrente, sin alteraciones en el examen físico.

Fuente: Urología, cuestionario 6.5, P10

45. Un paciente se autodetecta un tumor testicular derecho, asintomático, por lo que se solicita una ecografía testicular, que muestra un tumor redondeado, de 3 cm de diámetro y aspecto sólido. La conducta más adecuada es:

a. Observar evolución
b. Solicitar TAC de abdomen y pelvis
c. Realizar biopsia testicular, por punción con aguja
d. Realizar tumorectomía y biopsia

e. Realizar orquiectomía radical

Respuesta correcta: e. Realizar orquiectomía radical

Explicación: El estudio del tumor testicular se inicia con la ecografía testicular. Si demuestra un tumor sólido, se procede a la orquiectomía radical y biopsia (la biopsia mínima de un testículo es el testículo completo). Los marcadores tumorales (alfafetoproteína y HCG) se piden solo si hay un tumor sólido en la ecografía y no cambian conducta, ya que la orquiectomía radical debe hacerse de todas formas, eso sí, los marcadores sirven para el seguimiento, ya que si negativizan después de la cirugía, es posible asumir que se resecó todo el cáncer; en cambio, si vuelve a subir, puede haber una recidiva. Si la ecografía muestra un tumor quístico, simplemente se observa evolución, ya que es un quiste y no un cáncer.

Fuente: Urología, cuestionario 6.5, P17

Infección urinaria y prostatitis (9)

46. Una paciente de 60 años presenta un cuadro de disuria y orinas de mal olor, al que luego se agrega fiebre y marcado malestar general. Al examen físico está taquicárdica y desorientada. Se solicita un sedimento de orina que muestra abundantes piocitos, un hemograma con leucocitosis de 20.000 por mm3 y un urocultivo, cuyo resultado está pendiente. El tratamiento antibiótico más adecuado es:

a. Nitrofurantoína
b. Ceftriaxona
c. Ciprofloxacino
d. Imipinem
e. Cefadroxilo

Respuesta correcta: b. Ceftriaxona

Explicación: Tiene una pielonefritis aguda grave, de manejo hospitalario (por el compromiso de conciencia). Se trata con cefalosporinas endovenosas, siendo la más usada la ceftriaxona. - Si fuera alérgica, se podría usar la gentamicina o las quinolonas endovenosas (que actualmente están cada día más disponibles). - El imipenem sí la cubre, pero se excede en su espectro (además que es muy caro), por lo que solo se indica si el cultivo muestra una bacteria BLEE (betalactamasa de espectro expandido) o pseudomona. - La nitrofurantoína solo sirve en la ITU baja. - El ciprofloxacino y el cefadroxilo sí sirven tanto en la ITU baja como en las pielonefritis de manejo ambulatorio.

Fuente: Urología, cuestionario 6.1, P9

47. Un paciente de 66 años consulta por disuria dolorosa y fiebre alta. Además, presenta dolor al defecar. Se realiza un tacto rectal que es muy doloroso y se controla un antígeno prostático específico, que resulta muy elevado. El diagnóstico más probable es:

a. Hiperplasia prostática benigna complicada
b. Cáncer de próstata
c. Prostatitis aguda
d. Epididimitis
e. Litiasis vesical

Respuesta correcta: c. Prostatitis aguda

Explicación: Es una prostatitis aguda clásica: fiebre, disuria y dolor a la palpación prostática. Se diagnostica con la clínica (síntomas más tacto rectal, el que debe hacerse con mucho cuidado, ya que el tacto vigoroso puede generar bacteremia, por lo que está contraindicado); si queda la duda, se puede realizar el cultivo

seminal. Es causada principalmente por enterobacterias (E. coli y Proteus). Se trata con ciprofloxacino (en alérgicos, con cotrimoxazol) oral. En casos graves (ej. sepsis), con ceftriaxona.

Fuente: Urología, cuestionario 6.1, P11

48. Una niña de 6 años presenta un cuadro de disuria, por lo que se solicita un urocultivo, que muestra desarrollo de E. coli multisensible mayor a 100.000 UFC, la que es tratada con antibióticos orales, con buena respuesta. Usted la controla algún tiempo después, con un nuevo urocultivo, el que está negativo. La conducta más adecuada es:

a. Observar evolución
b. Solicitar una ecografía renal y vesical
c. Indicar profilaxis antibiótica
d. Solicitar cintigrafía renal estática
e. Solicitar TAC de abdomen y pelvis con contraste

Respuesta correcta: b. Solicitar una ecografía renal y vesical

Explicación: Las ITU en pediatría se deben estudiar, en busca de malformaciones y reflujo vesicoureteral. El examen mínimo es la ecografía renal y vesical. En el caso de que esté alterada, o si es una ITU febril en un lactante menor de 1 año, se realiza además la uretrocistografía y la cintigrafía estática DMSA. Sin embargo, estas recomendaciones no son compartidas por todos. De hecho, muchas recomendaciones internacionales solo indican el estudio de ITU febriles y no de las cistitis, usando los siguientes criterios: - Ecografía: solo en ITU febril que 1. primer episodio en menor de dos años, 2. segundo episodio a cualquier edad, 3. que no responde o 4. con clínica de falla renal. - UGC: solo en ITU febril que 1. tiene ecografía alterada, 2. segundo episodio, 3. germen distinto a E. coli o 4. clínica de falla renal. Por tanto, es una pregunta muy discutible.

Fuente: Urología, cuestionario 6.1, P14

49. Una mujer de 30 años presenta una pielonefritis aguda, la que se trata empíricamente con ciprofloxacino oral 500 mg c/12 horas. Usted la controla 3 días después y permanece con fiebre alta y decaimiento. Además, trae el resultado del urocultivo que se tomó al inicio del cuadro, que mostró desarrollo de un E. coli sensible a todos los antibióticos del antibiograma ocupado, el que incluye al ciprofloxacino. La conducta más adecuada es:

a. Mantener el tratamiento con ciprofloxacino y controlar ambulatoriamente en 7 días
b. Reemplazar el ciprofloxacino por cefadroxilo
c. Reemplazar el ciprofloxacino por nitrofurantoína
d. Reemplazar el ciprofloxacino por ceftriaxona
e. Solicitar una ecografía renal y vesical

Respuesta correcta: e. Solicitar una ecografía renal y vesical

Explicación: La conducta frente a una pielonefritis que no responde en 72 horas de tratamiento antibiótico, es estudiarla con ecografía, ya que se sospecha que se ha complicado (ej. con un absceso renal o con una pionefrosis por un cálculo). Algo similar ocurría con las neumonías, que no respondían en 72 horas, que se tenían que estudiar con una radiografía (por sospecha de complicación con absceso o derrame).

Fuente: Urología, cuestionario 6.1, P20

50. Una paciente de 20 años consulta por un cuadro de fiebre, malestar general y disuria dolorosa, de 24 horas de evolución. Al examen físico se aprecia febril hasta 39°C, con puño percusión positiva a izquierda.

Se solicita un sedimento de orina, que muestra piocituria de 30 por campo y un urocultivo, cuyo resultado está pendiente. ¿Qué tratamiento dejaría a esta paciente?

a. Solo tratamiento sintomático, a la espera del urocultivo
b. Amoxicilina oral
c. Metronidazol oral
d. Nitrofurantoína oral
e. Cefadroxilo oral

Respuesta correcta: e. Cefadroxilo oral

Explicación: Tiene una pielonefritis aguda, de manejo ambulatorio, ya que no tiene ningún criterio de severidad. Se puede tratar con cefadroxilo (cualquier cefalosporina de primera, segunda o tercera generación) o con quinolonas (ej. cirpofloxacino). La nitrofurantoína cubre solo ITU baja. La amoxicilina y el metronidazol no cubren E. coli.

Fuente: Urología, cuestionario 6.2, P10

51. Un paciente presenta un cuadro de fiebre, con disuria y dolor al defecar. Al examen físico destaca temperatura de 39°C y tacto rectal muy doloroso. El tratamiento antibiótico de elección para este paciente es:

a. Azitromicina oral
b. Doxiciclina oral
c. Ceftriaxona endovenosa
d. Cefadroxilo oral
e. Ciprofloxacino oral

Respuesta correcta: e. Ciprofloxacino oral

Explicación: Tiene una prostatitis aguda clásica, la que es causada por E. coli y se trata preferentemente con ciprofloxacino, ya que los demás antibióticos no se concentran adecuadamente en la próstata.

Fuente: Urología, cuestionario 6.3, P9

52. Una mujer de 18 años consulta por disuria y fiebre. Al examen está en buenas condiciones, con 39,0°C y puñopercusión positiva a derecha. Se solicita un sedimento de orina, que muestra abundantes bacterias y piocitos. El urocultivo está pendiente. La conducta más adecuada es:

a. Observar evolución, a la espera del resultado del urocultivo
b. Iniciar nitrofurantoína oral
c. Iniciar ciprofloxacino oral
d. Iniciar ceftriaxona endovenosa
e. Iniciar gentamicina más ceftriaxona endovenosa

Respuesta correcta: c. Iniciar ciprofloxacino oral

Explicación: Tiene una pielonefritis de tratamiento ambulatorio, porque no tiene ningún criterio de gravedad. Se debe tratar con antibióticos orales (cefalosporinas o quinolonas, como el ciprofloxacino), a la espera del urocultivo (se controla en 2 a 3 días). La nitrofurantoína solo cubre ITU baja y no pielonefritis. La ceftriaxona y la gentamicina se usan en las pielonefritis graves, de manejo hospitalizado (y en el embarazo se hospitaliza siempre y se trata con ceftriaxona o cefazolina).

Fuente: Urología, cuestionario 6.5, P4

53. El reflujo vesicoureteral (RVU) se suele complicar frecuentemente con:

a. Pielonefritis aguda
b. Nefrolitiasis
c. Retención urinaria aguda
d. Cáncer
e. Hematuria

Respuesta correcta: a. Pielonefritis aguda

Explicación: El RVU se complica con pielonefritis aguda y en segundo lugar con insuficiencia renal post-renal. De hecho, toda ITU en pediatría se estudia con ecografía y eventualmente con uretrocistografía, para descartar la presencia de RVU. Eso sí, algunas guías internacionales solo recomiendan estudiar las ITUs febriles en el primer episodio del menor de dos años o desde el segundo episodio a cualquier edad.

Fuente: Urología, cuestionario 6.5, P9

54. Una paciente de 35 años, cursando un embarazo de 30 semanas de gestación, consulta por disuria dolorosa, sin otras alteraciones. Se solicita un urocultivo, que resulta positivo para Escherichia coli multisensible. La conducta más adecuada es:

a. Observar evolución
b. Iniciar ciprofloxacino oral
c. Iniciar cefadroxilo oral
d. Iniciar ceftriaxona endovenosa
e. Iniciar gentamicina endovenosa

Respuesta correcta: c. Iniciar cefadroxilo oral

Explicación: Sobre la ITU en el embarazo se debe recordar lo siguiente: 1. Las bacteriurias asintomáticas se tratan igual que una ITU baja. 2. Las ITU bajas se tratan con cefalosporinas de primera generación (cefradina o cefadroxilo), porque está contraindicado el ciprofloxacino durante el embarazo (la nitrofurantoína sí se puede usar, pero se recomienda evitarla, en la medida de lo posible). 3. La pielonefritis agudas se hospitalizan y se tratan con cefalosporinas endovenosas. 4. Si tiene 2 o más infecciones tratadas, se debe indicar profilaxis con cefadroxilo, hasta que termine el embarazo.

Fuente: Urología, cuestionario 6.5, P15

Incontinencia urinaria y patología vesical (5)

55. Una paciente de 50 años consulta por dolor abdominal bajo, asociado a disuria dolorosa. Además, presenta polaquiuria y nicturia, con mucha frecuencia. Los síntomas aparecieron hace cerca de un año y cada vez han sido más frecuentes. Cuenta con múltiples sedimentos de orina y urocultivos que resultan negativos y con baciloscopías de orina, que también son negativas. El diagnóstico más probable es:

a. Tuberculosis renal
b. Bacteriuria asintomática
c. Cistitis intersticial
d. Cáncer de vejiga
e. Litiasis vesical

Respuesta correcta: c. Cistitis intersticial

Explicación: Es una cistitis intersticial clásica: cuadro crónico de dolor hipogástrico y síntomas de irritación vesical, sin una causa clara y con estudios negativos. Se debe realizar una cistocopía para descartar cáncer (se sospecharía si tuviese hematuria). El tratamiento suele ser con educación y analgésicos (AINES, tramadol con cuidado de evitar dependencia, analgésicos vesicales como fenazopiridina). Además, se indican moduladores del dolor (ej. tricíclicos), más el manejo del estrés.

Fuente: Urología, cuestionario 6.1, P10

56. Una paciente de 50 años consulta porque en 2 oportunidades ha presentado ganas incontrolables de orinar, por lo que no ha podido aguantarse y se ha mojado por completo. Su examen físico es normal y no presenta otros síntomas. La conducta más adecuada es:

a. Solicitar sedimento de orina y urocultivo
b. Solicitar exámenes de urodiamia
c. Iniciar oxibutinina
d. Solicitar ecografía renal y vesical
e. Iniciar nitrofurantoína

Respuesta correcta: a. Solicitar sedimento de orina y urocultivo

Explicación: Tiene clínica de una incontinencia urinaria de urgencia (urgeincontinencia o vejiga inestable). Si bien el diagnóstico es clínico, la primera medida siempre es descartar la infección urinaria. Los exámenes de urodinamia pueden pedirse para complementar la clínica, pero su única indicación real es ante la duda diagnóstica entre una incontinencia de esfuerzo y de urgencia. El manejo de la incontinencia urinario es algo discutible, con grandes variaciones según la fuente que se revise. A continuación, se resumen las recomendaciones de las guías norteamericanas: 1. Siempre descartar causas agudas (ej. ITU). Luego, de primera línea, realizar ejercicios de fortalecimiento de piso pélvico más cambios conductuales tanto en incontinencia de orina de esfuerzos (IOE) como en la de urgencia (IOU). 2. En IOE probar con pesarios o cirugía (cinta transvaginal, por ejemplo). 3. En IOU, de segunda línea, indicar fármacos. Los más usados son los anticolinérgicos (oxibutinina, tolterodina, trospio, darifenacina) y, recientemente, aparecieron los beta3-agonistas (mirabegrón y vibegrón). No hay evidencia de buena calidad que los compare, pero se debe sopesar los efectos adversos, precio y disponibilidad: a. Beta3-agonistas tienen menos efectos adversos. Si hay abundantes recursos, son de elección. b. Trospio y darifenacina no producen efectos cognitivos (existe miedo de que anticolinérgicos aumenten el riesgo de demencia, ya que hay asociación, aunque no se ha probado causalidad). Por tanto, son de elección al elegir un anticolinérgico. c. Oxibutinina es la más barata y usada. Tiene más efectos adversos que la tolterodina.

Fuente: Urología, cuestionario 6.1, P16

57. Un paciente de 45 años consulta por incontinencia urinaria, que inició hace 2 semanas, caracterizada por intensos deseos de orinar, que no logra aguantar, presentando escapes de grandes cantidades de orina. El examen físico es normal. La conducta más adecuada para proseguir el manejo de esta paciente es:

a. Iniciar oxibutinina
b. Iniciar ejercicios de Kegel y controlar evolución
c. Solicitar exámenes de urodinamia
d. Resolver quirúrgicamente
e. Solicitar sedimento de orina y urocultivo

Respuesta correcta: e. Solicitar sedimento de orina y urocultivo

Explicación: Tiene clínica de una incontinencia urinaria de urgencia (urgeincontinencia o vejiga inestable). Si bien el diagnóstico es clínico, la primera medida siempre es descartar la infección urinaria. Los exámenes de urodinamia pueden pedirse para complementar la clínica, pero su única indicación real es ante la duda diagnóstica entre una incontinencia de esfuerzo y de urgencia. - Los ejercicios de Kegel y la kinesioterapia pélvica en general son la primera línea del tratamiento de la incontinencia de esfuerzo. De última línea es la cirugía con un TOT o TVT. - La terapia conductual, rentrenamiento vesical y ejercicios de fortalecimiento del piso pélvico también son la primera línea del tratamiento de la incontinencia de urgencia. La tolterodina o la oxibutinina son los anticolinérgicos más usados, como tratamiento de segunda línea línea de la incontinencia de urgencia, aunque recientemente se recomienda más usar anticolinérgicos con menos efectos cognitivos como el cloruro de trospio y darifenacina e, idealmente, en la medida que existan recursos, de primera línea, se pueden usar los agonistas beta3 adrenérgicos (mirabegrón y vibegrón), que tienen aún menos efectos adversos.

Fuente: Urología, cuestionario 6.2, P9

58. Una mujer de 70 años presenta escape de pequeñas cantidades de orina ante situaciones como toser o realizar esfuerzos, que inició hace cerca de un año, pero que en el último tiempo ha empeorado, con síntomas al menos una vez por semana. Su examen físico es normal, al igual que su sedimento de orina. Su urocultivo es negativo. La conducta más adecuada es:

a. Solicitar ecografía abdominal
b. Resolver quirúrgicamente
c. Iniciar anticolinérgicos
d. Iniciar ejercicios de Koegel
e. Iniciar alfabloqueantes

Respuesta correcta: d. Iniciar ejercicios de Koegel

Explicación: Tiene una incontinencia de esfuerzo. El tratamiento sigue un orden: 1. Descartar ITU, con urocultivo y sedimento (ya se hizo), 2. Kinesioterapia pélvica, con ejercicio de Kegel u otros ejercicios de fortalecimiento pélvoco y 3. Cirugía: TVT o TOT.

Fuente: Urología, cuestionario 6.3, P3

59. Una paciente de 68 años presenta escape de orina al realizar esfuerzos físicos y en ocasiones al reírse o toser. Su examen físico es normal y su urocultivo es negativo, así como su sedimento de orina. Se indican ejercicios de Kegel, sin embargo, no se logra mejoría luego de algunos meses. La conducta más adecuada es:

a. Instalar sonda Foley
b. Iniciar anticolinérgicos
c. Iniciar inhibidores de la acetilcolinesterasa
d. Iniciar alfa-1 antagonistas
e. Resolver quirúrgicamente

Respuesta correcta: e. Resolver quirúrgicamente

Explicación: Tiene una incontinencia urinaria de esfuerzos. Se trata en el siguiente orden: 1. Decartar ITU, 2. Ejercicios de fortalecimiento del piso pélvico (ej. Kegel) y 3. Cirugía con cinta transobturatriz o transvaginal (TOT o TVT).

Fuente: Urología, cuestionario 6.5, P19

Trauma urológico (4)

60. Un paciente sufre un atropello, resultando con múltiples fracturas, las que se constatan con radiografía. Algunas horas después presenta imposibilidad de orinar, asociado a dolor. Al examen se aprecia un globo vesical y sus calzoncillos están manchados con sangre, observándose escasa sangre en el meato urinario. La conducta inicial más adecuada es:

a. Solicitar un TAC de abdomen y pelvis
b. Instalar una sonda Foley
c. Realizar cistostomía suprapúbica
d. Solicitar una ecografía vesical
e. Resolver quirúrgicamente de inmediato

Respuesta correcta: c. Realizar cistostomía suprapúbica

Explicación: Tiene una lesión uretral clásica: retención urinaria y uretrorragia, en relación a una fractura de pelvis. Inicialmente, se trata con cistostomía suprapúbica; luego, se realiza una uretrocistografía y finalmente se debe resolver quirúrgicamente. La sonda Foley está absolutamente contraindicada.

Fuente: Urología, cuestionario 6.1, P4

61. Un paciente sufre un accidente de tránsito, con contusión lumbar y algunas fracturas costales. Presenta además hematuria en varias oportunidades. ¿Qué examen es más adecuado para el estudio de este paciente, dada la sospecha diagnóstica?

a. Cintigrafía DMSA
b. Pielografía de eliminación
c. Uretrocistografía retrógrada
d. TAC de abdomen y pelvis
e. Cistoscopía

Respuesta correcta: d. TAC de abdomen y pelvis

Explicación: La sospecha diagnóstica es un trauma renal (trauma lumbar con hematuria), el que se estudia con TAC con contraste, de abdomen y pelvis. No se debe confundir con el trauma uretral (fractura pélvica con uretrorragia), que se estudia con la uretrocistografía. Eso sí, en el trauma renal con hemodinamia inestable, el examen de elección es la exploración quirúrgica, ya que las hemorragias no necesariamente provienen de los riñones y se debe descartar otras lesiones.

Fuente: Urología, cuestionario 6.3, P8

62. Un paciente de 30 años consulta porque presento dolor intenso en el pene mientras mantenía relaciones sexuales con su novia, evolucionando con aumento de volumen. Al examen físico se aprecia edema y equimosis del pene, con intenso dolor. El diagnóstico más probable es:

a. Priapismo
b. Parafimosis
c. Balanitis
d. Fractura de pene
e. Trombosis de la vena dorsal del pene

Respuesta correcta: d. Fractura de pene

Explicación: Tiene una fractura de pene clásica (¡ouch!). Suele ocurrir durante las relaciones sexuales con una mala técnica, en especial cuando el pene sale de la vagina y luego choca con el pubis, doblándose. Es

frecuente que se produzca un chasquido y dolor. Se diagnostica con la clínica y se resuelve quirúrgicamente de inmediato. La demora en la reparación quirúrgica puede producir desviación del pene, disfunción eréctil y dispareunia. - El priapismo, en cambio, es una erección dolorosa de los cuerpos cavernosos, mayor a 4 horas, con flacidez de los cuerpos esponjosos y el glande.

Fuente: Urología, cuestionario 6.4, P2

63. Un paciente sufre un accidente de tránsito, con fractura de pelvis. Al examen físico presenta salida de sangre fresca por la uretra. El diagnóstico de sospecha es:

a. Estallido vesical
b. Lesión de los cuerpos cavernosos
c. Sección uretral
d. Contusión renal
e. Laceración renal

Respuesta correcta: c. Sección uretral

Explicación: Es una sección uretral clásica: antecedente de trauma pélvico y uretrorragia (además, suele tener retención urinaria aguda, con globo vesical). Está contraindicada la sonda Foley, por lo que se maneja con cistostomía suprapúbica y luego, cirugía. El estallido vesical se asocia a trauma abdominal bajo y solo presenta dolor e insuficiencia renal, sin globo vesical, ya que la orina se filtra hacia el peritoneo. También puede presentarse con hematuria. La lesión de cuerpos cavernosos se produce durante las relaciones sexuales (fractura de pene) y se caracteriza por dolor y hematoma peneano. El trauma renal se asocia a trauma lumbar y se presenta con hematuria, no con uretrorragia. 1.- Fiebre postquirúrgica

Fuente: Urología, cuestionario 6.5, P20

Patología del pene y prepucio (4)

64. Las balanopostitis en el paciente adulto son más frecuentemente causadas por:

a. Cándida albicans
b. Escherichia coli
c. Anaerobios
d. Trichomona vaginalis
e. Estafilococo áureo

Respuesta correcta: a. Cándida albicans

Explicación: En los adultos, las balanopostitis son candidiásicas y se asocian a la diabetes mellitus. Las otras causas (mycoplasma, tricomonas, etc.) son mucho menos frecuentes. En los niños antes del inicio de las relaciones sexuales, suelen ser por S. aureus.

Fuente: Urología, cuestionario 6.1, P13

65. Un paciente de 3 años presenta fimosis. No ha presentado infecciones urinarias ni balanopostitis, sin embargo, es imposible retraer el prepucio y visualizar el glande por completo. La conducta más adecuada es:

a. Observar evolución
b. Solicitar ecografía inguinoescrotal
c. Iniciar corticoides tópicos
d. Realizar circuncisión

e. Realizar retracción forzada del prepucio

Respuesta correcta: a. Observar evolución

Explicación: La fimosis en menores de 4 años simplemente se observa y es más, no debería siquiera diagnosticarse. La excepción son los niños con complicaciones, como balanopostitis, ITU recurrente o parafimosis. En los mayores de 4 años, en cambio, se deben circuncidar, aunque es correcto intentar un tratamiento con corticoides tópicos por 2 semanas, antes de proceder a la cirugía y muchas guías lo recomiendan, al ser eficaces y baratos (ej. betametasona 1% tópica, dos veces al día por 4-6 semanas).

Fuente: Urología, cuestionario 6.2, P4

66. Un paciente presenta una lesión en el glande, de una semana de evolución, caracterizada por una úlcera de 1 cm, de bordes bien definidos, indolora. El tratamiento de elección es:

a. Ciprofloxacino
b. Ceftriaxona
c. Aciclovir
d. Penicilina benzatina
e. Doxiciclina

Respuesta correcta: d. Penicilina benzatina

Explicación: Tiene un chancro clásico, es decir, una sífilis primaria, que se trata con penicilina benzatina.

Fuente: Urología, cuestionario 6.4, P3

67. Un paciente de 20 años presenta una parafimosis, la que es reducida manualmente a tiempo, sin sufrir complicaciones. Al examen físico se aprecia un anillo fimótico. La conducta más adecuada es:

a. Observar evolución
b. Indicar corticoides tópicos por 4 semanas y controlar ambulatoriamente
c. Indicar tratamiento antibiótico tópico
d. Solicitar urocultivo y sedimento de orina
e. Realizar circuncisión

Respuesta correcta: e. Realizar circuncisión

Explicación: Tanto por ser adulto, como por haberse complicado con una parafimosis, es mandatorio resolver quirúrgicamente la fimosis de este paciente, mediante la circuncisión.

Fuente: Urología, cuestionario 6.5, P11

Uretritis (3)

68. Un paciente de 36 años consulta por disuria intensa. Refiere además que mancha los calzoncillos con secreción. Al examen físico se aprecia secreción uretral purulenta. ¿Qué examen es más adecuado para proseguir el estudio?

a. VDRL
b. Tinción de Tzank
c. Cultivo de secreción uretral
d. Gram de secreción uretral
e. Microscopía de campo oscuro de secreción uretral

Respuesta correcta: d. Gram de secreción uretral

Explicación: Tiene una uretritis clínica: disuria y secreción uretral. Se estudia con Gram de secreción uretral en los hombres y con Cultivo de Thayer Martin o PCR en las mujeres. Así es posible diferenciarla entre uretritis gonocócica y no gonocócica, con tratamientos distintos. Eso sí, es aceptable realizar exámenes microbiológicos en hombres en la práctica médica real, en busca de identificar los agentes específicos que causan sus síntomas y así tratarlo a él y a sus parejas sexuales.

Fuente: Urología, cuestionario 6.2, P7

69. ¿Cuál es el tratamiento de elección de la uretritis no gonocócica?

a. Ceftriaxona
b. Ciprofloxacino
c. Doxiciclina
d. Penicilina
e. Cefadroxilo

Respuesta correcta: c. Doxiciclina

Explicación: La uretritis no gonocócica se trata de preferencia con doxiciclina 100 mg vo, cada 12 horas por 10 días. Como alternativa está la azitromicina 1 gramo vo, por 1 vez. La gonocócica, en cambio, se trata con ceftriaxona 250 a 500 mg im, por 1 vez (o cirpofloxacino 500 mg vo por 1 vez, o azitromicina 2 gramos vo, por una vez), más cobertura para uretritis no gonocócica.

Fuente: Urología, cuestionario 6.3, P10

70. ¿Cuál de los siguientes es un tratamiento adecuado para un paciente con una uretritis no gonocócica?

a. Ciprofloxacino oral
b. Ceftriaxona intramuscular
c. Azitromicina oral
d. Clindamicina oral
e. Penicilina benzatina intramuscular

Respuesta correcta: c. Azitromicina oral

Explicación: La uretritis no gonocócica se trata de preferencia con doxiciclina 100 mg vo, cada 12 horas por 10 días. Como alternativa está la azitromicina 1 gramo vo, por 1 vez (es la única opción aceptable, entre las enumeradas). La gonocócica, en cambio, se trata con ceftriaxona 250 a 500 mg im, por 1 vez (o cirpofloxacino 500 mg vo por 1 vez, o azitromicina 2 gramos vo, por una vez), más cobertura para uretritis no gonocócica.

Fuente: Urología, cuestionario 6.5, P12

Cirugía (81)

Abdomen agudo y obstrucción intestinal (11)

1. Un paciente de 68 años consulta por dolor abdominal muy intenso (10/10), que inició hace tres horas y se asoció a vómitos alimentarios en una oportunidad. Dolor está distribuido en todo el abdomen, el cual es blando y depresible a la palpación y no presenta signos de irritación peritoneal. En el resto del examen físico, destaca un ritmo irregular en el pulso. ¿Qué examen es el más adecuado para definir el diagnóstico de sospecha?

a. Radiografía de abdomen simple de pie
b. Ecografía abdominal
c. Resonancia magnética nuclear de abdomen
d. Angiografía por tomografía axial computada de abdomen
e. Colangiografía pancreática retrógrada endoscópica

Respuesta correcta: d. Angiografía por tomografía axial computada de abdomen

Explicación: La sospecha es una embolia mesentérica, dado el inicio súbito muy intenso y el examen abdominal sin signos peritoneales en las primeras horas (la clásica disociación entre la intensidad del dolor y la normalidad del examen abdominal). Por tanto, se debe estudiar con angioTAC (sin contraste intestinal, pero con contraste endovenoso y técnica de angiografía por TAC) urgente o una angiografía mesentérica, siendo actualmente de elección la angioTAC si está disponible para ser realizada e informada de inmediato. El pulso irregular sugiere una fibrilación auricular. La isquemia mesentérica suele asociarse a acidosis metabólica con mucha frecuencia. En los casos en que la isquemia mesentérica progresa a signos peritoneales (no es este caso) y se sospecha que hay un infarto intestinal irrecuperable o una perforación, se va directamente a una laparotomía exploradora, sin siquiera solicitar el angioTAC. La revascularización clásicamente se hace con cirugía abierta, pero también se puede hacer por vía endovascular.

Fuente: Cirugía, cuestionario 8.1, P1

2. Un paciente de 35 años consulta por dolor abdominal alto de un día devolución, muy intenso que hay ido aumentando y se ha asociado a vómitos alimentarios. En el examen físico se aprecia dolor a la palpación del hemiabdomen superior, especialmente intenso en el hipocondrio derecho. Los ruidos hidroaéreos están presentes y no presenta signos de irritación peritoneal. La conducta más adecuada es:

a. Solicitar una ecografía abdominal
b. Resolver quirúrgicamente de inmediato
c. Indicar analgésicos orales y enviar a domicilio
d. Solicitar una tomografía axial computada de abdomen y pelvis con contraste
e. Solicitar una colangioresonancia

Respuesta correcta: a. Solicitar una ecografía abdominal

Explicación: Solo tiene dolor y vómitos y no ictericia (no se sospecha ni colangitis ni colédocolitiasis). Dado que el dolor ha durado 1 día, lo más probable es que sea una colecistitis aguda, aunque no se puede descartar la pancreatitis. Lo más correcto sería pedir la ecografía (por la colecistitis aguda), más una lipasa (descartar la pancreatitis), más exámenes generales (hemograma y pruebas hepáticas).

Fuente: Cirugía, cuestionario 8.1, P3

3. Paciente de 65 años consulta por dolor abdominal tipo cólico, intenso que inició hace seis horas. Pues ha presentado abundantes vómitos alimentarios en 10 oportunidades. El examen abdominal se aprecia una cicatriz de colecistectomía abierta (hace 10 años), distensión importante, asociada a un claro aumento de los ruidos hidro aéreos. Además, la palpación es dolorosa de manera difusa, con algún grado de resistencia muscular. ¿Qué examen es más adecuado para establecer el diagnóstico en este paciente?

a. Tomografía axial computada
b. Ecografía abdominal
c. Radiografía de abdomen simple
d. Resonancia magnética nuclear
e. Lipasa plasmática

Respuesta correcta: c. Radiografía de abdomen simple

Explicación: El cuadro clínico clásico de la obstrucción intestinal (dolor cólico, distensión abdominal y náuseas / vómitos) suele ser la base del diagnóstico, especialmente en pacientes con factores de riesgo (cirugías previas para bridas o hernias). Es más, en los casos en que hay irritación peritoneal o una hernia atascada evidente, se procede a la cirugía directamente. En los casos en que está bien (hemodinámicamente estable, sin signos de isquemia ni de peritonitis), se suele proceder a una imagen, siendo tanto radiografías simples como TAC las más importantes. Las radiografías son rápidas y ayudan a confirmar el diagnóstico y localizar la altura de la obstrucción. La TAC visualiza mejor la anatomía y permite identificar el sitio exacto de obstrucción y la etiología (especialmente útil en cáncer de colon). Por tanto, es muy discutible decidir qué examen iniciar. Sin embargo, las recomendaciones internacionales son las siguientes: - Si se sospecha una obstrucción de intestino delgado (ej. bridas y mucho vómito): comenzar con radiografías simples y luego pedir la TAC. Es lo sospechado en este caso. - Si se sospecha una obstrucción de colon (ej. clínica de cáncer como baja de peso o imposibilidad de eliminar gases por el ano): ir directamente a la TAC. El tratamiento es quirúrgico.

Fuente: Cirugía, cuestionario 8.1, P5

4. Un paciente de 80 años presenta dolor abdominal epigástrico, intenso, que luego migra a la fosa ilíaca derecha, aumentando en intensidad. Al examen físico presenta signo de Blumberg y resistencia muscular en la zona. Sus signos vitales muestran Tº: 38º, PA: 120/80 mmHg y FC: 94x'. La conducta más adecuada, de acuerdo a las recomendaciones actualizadas, es:

a. Solicitar colonoscopía de urgencia
b. Resolver mediante cirugía de inmediato sin necesidad de exámenes
c. Solicitar TAC de abdomen y pelvis
d. Solicitar angiografía mesentérica
e. Administrar analgésicos y antibióticos y observar evolución

Respuesta correcta: c. Solicitar TAC de abdomen y pelvis

Explicación: Históricamente el diagnóstico de la apendicitis ha sido clínico, pero, en los últimos años se ha afianzado la recomendación de confirmarla con imágenes, debido a tres razones: 1. Se realizaban muchas apendicectomías en blanco, 2. Se pasaban por alto otras patologías que requerían tratamiento urgente y 3. Se subdiagnosticaban apendicitis en las etapas iniciales o retrocecales, que no cumplían con la clínica completa (ej. no tenían signos peritoneales por estar en las etapas iniciales o por ser una apendicitis retrocecal). Se ha desarrollado el score de Alvarado, que incluye siete variables: - 2 puntos: Signos peritoneales localizados como Blumblerg y Rosving. - 2 puntos: Leucocitosis (2 puntos) - 1 punto: Dolor migratorio a la FID. - 1 punto: Dolor a la palpación en FID. - 1 punto: Anorexia (inespecífico). - 1 punto: Náuseas o vómitos (inespecífico). - 1 punto: Fiebre >37,5ºC (inespecífico). Con 4 puntos ya es necesario

realizar una imagen. En la práctica, los signos peritoneales en FID ya tienen 4 en conjunto, solo suman 3 puntos. La mejor imagen para hacer el diagnóstico es la TAC de abdomen y pelvis, pero es aceptable utilizar una ecografía abdominal, en especial si no está disponible la TAC. En el caso de las mujeres en edad fértil, debido a que tienen un amplio abanico de diagnósticos diferenciales que producen algia pélvica, se recomienda complementar no solo con test de embarazo, sino también con una imagen que vea bien las estructuras ginecológicas, como la RMN de pelvis o la ecografía transvaginal. El tratamiento es quirúrgico.

Fuente: Cirugía, cuestionario 8.2, P5

5. ¿Cuál de los siguientes cuadros clínicos es más sugerente de una embolia mesentérica?

a. Paciente 68 años con dolor abdominal tipo cólico, asociado a distensión abdominal y vómitos alimentarios

b. Paciente de 58 años con dolor abdominal transfixiante, asociado a abdomen en tabla

c. Paciente de 60 años con dolor abdominal intenso, de inicio súbito, con abdomen blando y sin signos peritoneales

d. Paciente de 70 años con dolor abdominal y hematoquezia de 5 día des evolución

e. Paciente de 65 años con dolor abdominal de inicio súbito, con compromiso hemodinámico y presencia de masa abdominal pulsátil

Respuesta correcta: c. Paciente de 60 años con dolor abdominal intenso, de inicio súbito, con abdomen blando y sin signos peritoneales

Explicación: La embolia mesentérica se caracteriza por iniciar de manera súbita, con dolor muy intenso y es característica la "disociación entre el dolor y el examen físico", ya que duele mucho, pero no tiene signos peritoneales (al menos no al principio, ya que después sí aparecen, cuando ya hay necrosis y perforación). Además, es frecuente que al inicio haya vómitos y diarrea. Se debe estudiar con angioTAC (sin contraste intestinal, pero con contraste endovenoso y técnica de angiografía por TAC) urgente o una angiografía mesentérica, siendo actualmente de elección la angioTAC si está disponible para ser realizada e informada de inmediato. La revascularización clásicamente se hace con cirugía abierta, pero también se puede hacer por vía endovascular. Si progresa a signos peritoneales y se sospecha que hay un infarto intestinal irrecuperable o una perforación, se va directamente a una laparotomía exploradora, sin siquiera solicitar el angioTAC. - La opción A es una obstrucción intestinal. - La opción B es una úlcera péptica perforada. - La opción D puede ser una trombosis de la vena mesentérica o una colitis isquémica. - La opción E es un aneurisma roto de la aorta abdominal.

Fuente: Cirugía, cuestionario 8.3, P7

6. Una paciente presenta dolor abdominal intenso en el hipocondrio derecho, asociado a vómitos alimentarios y sensación febril, de 24 horas de evolución. Refiere que el dolor no la dejó dormir, por lo que consulta en el servicio de urgencia. Al examen físico se presenta dolor a la palpación abdominal, en especial a la palpación del hipocondrio derecho. No presenta signos peritoneales. En sus exámenes destaca lipasa: 60 UI/L, GOT: 30 UI/L, Bili: 1,0 mg/dl, FA: 98 UI/L y hemograma con leucocitosis de 15.800 por mm3. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

a. Solicitar TAC de abdomen y pelvis

b. Solicitar ecografía abdominal

c. Realizar laparotomía exploradora

d. Solicitar radiografía de abdomen de pie

e. Administrar analgésico y antiespasmódicos y observar evolución

Respuesta correcta: b. Solicitar ecografía abdominal

Explicación: La sospecha abdominal es una colecistitis aguda, ya que tiene dolor en hipocondrio derecho, más signos de infección (fiebre, leucocitosis). Lo primero es confirmar el diagnóstico, con una ecografía abdominal y luego proceder a la colecistectomía laparoscópica de urgencia. * La pancreatitis (que puede tener la misma clínica) fue descartada con la lipasa normal (valores normales son muy variables, hasta 140 UI/L en la mayoría de laboratorios). Para el diagnóstico de pancreatitis se requiere que esté elevada por 2 o 3 veces por sobre lo normal (según la fuente) o que esté elevada bajo 2 veces el límite, pero con una TAC compatible. En resumen, el diagnóstico se hace solo con lipasa si está 2 o 3 veces sobre el nivel máximo, o con lipasa elevada más TAC.

Fuente: Cirugía, cuestionario 8.3, P13

7. Un paciente de 68 años presenta dolor abdominal intenso, tipo cólico, asociado a vómitos alimentarios. Al examen se aprecia distensión abdominal y aumento de los ruidos abdominales. Se solicita una radiografía de abdomen simple, que se muestra a continuación: El diagnóstico más probable es:

a. Diverticulitis aguda
b. Obstrucción intestinal por vólvulo
c. Cáncer de colon perforado
d. Embolia mesentérica
e. Íleo biliar

Respuesta correcta: b. Obstrucción intestinal por vólvulo

Explicación: En la radiografía se ve la imagen en "grano de café", característica del vólvulo. Su clínica es de obstrucción intestinal. - En primera instancia se trata con descompresión neumática (se introduce el sigmoscopio o colonoscopio y se insufla lentamente, logrando la destorsión). - En segunda instancia se opera electivamente para evitar recurrencias, con una sigmoidectomía y anastomosis primaria.

Fuente: Cirugía, cuestionario 8.4, P8

8. ¿Qué examen es el de elección para la evaluación del dolor abdominal en el adulto mayor, cuando se sospecha que puede corresponder a una patología grave, sin tener un diagnóstico clínico claro?

a. Ecografía abdominal
b. Radiografía de abdomen simple
c. TAC de abdomen y pelvis
d. Resonancia magnética nuclear de abdomen y pelvis
e. Laparotomía exploradora

Respuesta correcta: c. TAC de abdomen y pelvis

Explicación: El examen de elección para el estudio del dolor abdominal (color abdominal que puede corresponder a una patología grave) en el adulto mayor es el TAC abdominal. Incluso, en el caso de que sea una apendicitis clínica categórica, actualmente se prefiere confirmar con imágenes (idealmente TAC), antes de proceder a la cirugía. Si la clínica es característica de otra patología, sí se estudia según la sospecha (ej. si parece una embolia mesentérica, se solicita angioTAC).

Fuente: Cirugía, cuestionario 8.4, P10

9. Un paciente de 50 años presenta dolor abdominal de 12 horas de evolución, que inició en el hemiabdomen superior y se asoció a vómitos alimentarios en varias oportunidades. Tomó antiespasmódicos, con disminución parcial del dolor, pero luego el dolor fue aumentando, localizándose en el hipocondrio derecho. Al examen físico presenta PA: 120/80 mmHg, FC: 90x', T°: 38,2°C y abdomen

blando, doloroso en el hemiabdomen superior, siendo mucho más intenso al palpar el hipocondrio derecho. El diagnóstico de sospecha es:

a. Cólico biliar simple
b. Colecistitis aguda
c. Conlangitis aguda
d. Colédocolitiasis
e. Pancreatitis aguda

Respuesta correcta: b. Colecistitis aguda

Explicación: Tiene el dolor y fiebre. La localización en el hipocondrio derecho es característica. No tiene ictericia, así que no parece ni colangitis ni coledocolitiasis. La fiebre y la duración hace poco probable un cólico biliar simple. Sí puede ser una pancreatitis (se debe pedir lipasa), pero el dolor en ella suele irradiarse en faja y ser de localización epigástrica, por lo que es más probable la colecistitis (también se debe pedir la ecografía).

Fuente: Cirugía, cuestionario 8.4, P11

10. Una paciente de 35 años presenta dolor abdominal muy intenso, que se localizó inicialmente el el epigastrio y luego se volvió difuso. Al examen físico se aprecian signos peritoneales marcados y la radiografía de abdomen simple demuestra neumoperitoneo. La conducta más adecuada es:

a. Resolver quirúrgicamente de inmediato
b. Indicar omeprazol endovenoso y antibióticos de amplio espectro
c. Solicitar angiogragía mesentérica de urgencia
d. Solicitar TAC de abdomen y pelvis de urgencia
e. Indicar régimen cero, administrar analgésicos y suero fisiológico por vía endovenosa

Respuesta correcta: a. Resolver quirúrgicamente de inmediato

Explicación: La clínica y el neumoperitoneo hace pensar en primer lugar en una úlcera perforada. La cirugía es lo más importante: laparotomía exploradora, con sutura de la úlcera y parche de epiplón. Sí se deben dar antibióticos y omeprazol, pero la cirugía es la respuesta, por ser lo más importante.

Fuente: Cirugía, cuestionario 8.4, P14

11. Un niño de 5 días de vida, con antecedente de asfixia, presenta vómitos, asociado a hematoquezia. Al examen físico se aprecia distensión abdominal. El diagnóstico más probable es:

a. Atresia esofágica
b. Atresia duodenal
c. Invaginación intestinal
d. Estenosis hipertrófica del píloro
e. Enterocolitis necrotizante

Respuesta correcta: e. Enterocolitis necrotizante

Explicación: Tiene el antecedente de prematurez y la triada clásica de la enterocolitis necrotizante: distensión abdominal, hematoquezia y vómitos/retención gástrica (en la sonda nasogástrica). La atresia esofágica produce sialorrea y dificultad respiratoria desde el nacimiento. La atresia duodenal tiene vómitos y deshidratación desde el nacimiento. La invaginación tiene dolor, llanto y hematoquezia después de los 6 meses de vida. La estenosis hipertrófica pilórica tiene vómitos explosivos, que inician a las 2-6 semanas de vida.

Fuente: Cirugía, cuestionario 8.4, P15

Patología biliar y pancreática (9)

12. Un paciente de 55 años es diagnosticado de pancreatitis aguda, la que es manejada de manera médica, con evolución satisfactoria. Usted lo evalúan tres semanas después, persistiendo con algún grado de dolor. La tomografía de control demuestra la presencia de un pseudoquiste de 5 cm de diámetro, sin otras alteraciones. La conducta más adecuada es:

a. realizar Colangiografía pancreática retrógrada endoscópica
b. resolver quirúrgicamente
c. solicitar una ecografía abdominal
d. solicitar niveles plasmáticos de lipasa
e. observar evolución

Respuesta correcta: e. observar evolución

Explicación: El pseudoquiste es una complicación frecuente de la pancreatitis, que suele observarse, a menos que sea “satánico” (666: 6 semanas, 6 cm y "seistomas": síntomas). En este caso no se cumplen dichos criterios, por lo que no está indicada la cirugía. Eso sí, muchas guías simplifican el manejo, diferenciando entre pseudoquistes asintomáticos, que se observan y pseudoquistes sintomáticos (dolor o ictericia) o complicados (ej. infección, obstrucción), que se drenan, ya sea por punción por vía endoscópica o percutánea, dependiendo de las características y ubicación del pseudoquiste, dejando la cirugía a los casos en que el drenaje por punción falla.

Fuente: Cirugía, cuestionario 8.1, P7

13. Un paciente de 64 años, bebedor habitual, comienza con dolor abdominal recurrente, que se presenta luego de comer y luego de consumir alcohol. Su examen físico es normal y en sus exámenes generales destaca glicemia basal: 170 mg/dl. El diagnóstico más probable es:

a. Cáncer de páncreas
b. Angina mesentérica
c. Pancreatitis crónica
d. Colelitiasis
e. Hepatocarcinoma

Respuesta correcta: c. Pancreatitis crónica

Explicación: Tiene una pancreatitis crónica clásica: antecedente de alcoholismo, con dolor abdominal recurrente, postprandial. Además, suele complicarse con malabsorción intestinal y con diabetes (como en este caso, que tiene una glicemia de ayuno mayor a 126, la que debe repetirse para confirmar el diagnóstico). El tratamiento de esta diabetes requeriría de insulina, por ser causada por un déficit en la secreción del páncreas endocrino. El mejor examen para diagnosticarla es indistintamente la TAC de abdomen o la colangiopancreatografía por RMN. Un porcentaje menor de pacientes no tienen síntomas y, en ellos, el diagnóstico se hace como hallazgo en una imagen que muestra las alteraciones características de la pancreatitis crónica (radiografía, TAC o ecografía pueden mostrarlas y, en ese caso, suele ser diagnóstica, a pesar de no haberse solicitado el mejor examen y solo haber sido un hallazgo) - La angina mesentérica también tiene dolor postprandial, pero con antecedente de factores de riesgo cardiovascular. El cáncer de páncreas se caracteriza por dolor abdominal crónico, inespecífico, diabetes y depresión, más ictericia obstructiva. La colelitiasis tiene cólico biliar (dolor de 20 a 30 minutos, con vómitos en hipocondrio derecho o epigastrio).

Fuente: Cirugía, cuestionario 8.2, P4

14. Un paciente de 60 años presenta dolor epigástrico muy intenso, asociado a vómitos, que inició hace 5 horas. El examen físico presenta dolor al palpar el epigastrio, sin signos peritoneales. Se solicitan exámenes que muestran GOT: 64 UI/L, GPT: 50 UI/L, GGT: 210 UI/L, FA: 423 UI/L, amilasa: 30 UI/L, lipasa: 34 UI/L, bilirrubina total: 3,5 mg/dl, bilirrubina directa: 3,0 mg/dl. El diagnóstico de sospecha es:

a. Cáncer
b. Colecistitis aguda
c. Colangitis aguda
d. Colédocolitiasis
e. Pancreatitis aguda

Respuesta correcta: d. Colédocolitiasis

Explicación: Es una coledocolitiasis, ya que tiene dolor y colestasia. Si bien no se describe la ictericia, las pruebas hepáticas confirman una colestasia: GGT, FA y bilirrubina (directa) elevadas. No hay hepatitis (GPT y GGT normales), ni pancreatitis (amilasa y lipasa normales). El cáncer puede producir colestasia, pero generalmente sin dolor (y si tiene dolor es leve y crónico). Ante la sospecha de coledocolitiasis, el primer examen es la ecografía abdominal. La colangioRMN suele ser el mejor examen y se usa para confirmar. La CPRE es diagnóstico y terapéutico. Luego se hace la cirugía. La CPRE, por tanto, se hará cuando la colangioRMN confirma el diagnóstico. Pero, también se hace directamente la CPRE, sin colangioRMN en los siguientes casos: - Tiene clínica de colangitis aguda. - Ecografía ve los cálculos en el colédoco. - Algunos agregan que ecografía tenga dilatación del colédoco >7 mm, más bilirrubina > 4 mg/dl.

Fuente: Cirugía, cuestionario 8.2, P8

15. Un paciente de 45 años sufre una pancreatitis aguda litiásica grave, que evoluciona con marcado deterioro del

a. Mantener régimen cero e hidratación endovenosa, sin necesidad de antibióticos
b. Iniciar antibióticos orales y realimentar al paciente
c. Indicar nutrición parenteral total y antibióticos por vía endovenosa
d. Administrar analgésicos y antibióticos de amplio espectro por vía endovenosa, controlando con nuevo TAC
e. Resolver quirúrgicamente, bajo cobertura antibiótica, de inmediato

Respuesta correcta: e. Resolver quirúrgicamente, bajo cobertura antibiótica, de inmediato

Explicación: El tratamiento básico es 1. Régimen cero, 2. Hidratación endovenosa y 3. Analgésicos (AINEs). En los casos leves no suele ser necesario alimentar por otras vías y la realimentación oral se puede reiniciar a los pocos días. En los casos moderados a severos, se suele recomendar la nutrición enteral (por sonda), ya que tiene menos complicaciones y costos que la parenteral. Los antibióticos están indicados en la necrosis infectada, la cual debe ser sospechada en toda pancreatitis grave o que evoluciona mal. La punción con aguja fina y cultivo sirven, pero la clínica parece ser el mejor indicador, por lo que muchos no recomiendan la punción. Se usan carbapenémicos solos o cefepime más metronidazol. Por tanto, en este caso, si no hubiese salido el resultado de la punción, el tratamiento habría sido el mismo. La cirugía está reservada a los casos con necrosis infectada y paciente grave (ej. hemodinamia inestable, como en este caso) o que, usando antibióticos, empeora o no revierte en 4 semanas. La causa debe ser tratada (ej. realizar colecistectomía en litiasis, suspender el alcohol y tratar hipertrigliceridemia). En los casos en que

la causa sospechada es la litiasis, además, se recomienda una CPRE urgente, para retirar el cálculo del colédoco.

Fuente: Cirugía, cuestionario 8.3, P2

16. Una paciente de 32 años se realiza una colecistectomía laparoscópica, de manera electiva, por padecer de colelitiasis asintomática. ¿Requiere de antibióticos?

a. No, los antibióticos no son necesarios
b. Sí, requiere profilaxis antibiótica durante la cirugía
c. Sí, requiere profilaxis antibióticas durante el día de la cirugía y los 3 días siguientes
d. Sí, requiere profilaxis antibióticas durante el día de la cirugía y los 7 días siguientes
e. Sí, requiere profilaxis antibióticas durante los 3 días previos a la cirugía y los 7 días siguientes

Respuesta correcta: b. Sí, requiere profilaxis antibiótica durante la cirugía

Explicación: La colecistectomía es una herida limpia-contaminada, ya que abre mucosas. Debe recibir profilaxis antibiótica en la cirugía. - Las heridas limpias (no abren mucosas), salvo excepciones, no requieren antibióticos. - Las heridas limpias-contaminadas (abren mucosas) y las heridas contaminadas (cortan tejido inflamado o pierden la técnica aséptica) sí requieren antibióticos profilácticos, pero solo durante la cirugía (se administran una hora antes, habitualmente). - Las heridas sucias o infectadas (contacto con pus, con deposiciones o con signos clínicos de infección) requieren antibióticos como tratamiento, por 7 a 10 días.

Fuente: Cirugía, cuestionario 8.3, P11

17. Un paciente de 67 años presenta astenia, asociada a ictericia, de cerca de un mes de evolución. Refiere además coluria, sin otros síntomas. En sus pruebas hepáticas se constata GOT: 54 UI/L, GPT: 66 UI/L, GGT: 190 UI/L, FA: 520 UI/L, BiliT: 5,3 mg/dl, BiliD: 5,0 mg/dl. El diagnóstico más probable es:

a. Colecistitis aguda
b. Pancreatitis crónica
c. Cáncer
d. Colédocolitiasis
e. Colangitis aguda

Respuesta correcta: c. Cáncer

Explicación: Tiene una ictericia colestásica, sin dolor. Es decir, una ictericia silente, cuya causa más frecuente es el cáncer, con obstrucción de la vía biliar. Las pruebas hepáticas muestran una colestasia: elevación de la GGT, FA y bilirrubina directa. El estudio de la colestasia inicia con ecografía abdominal. Si la causa parece ser obstrucción biliar, pero no se identifica bien la causa en la ecografía, se procede a la colangioRMN, examen de mayor rendimiento.

Fuente: Cirugía, cuestionario 8.3, P20

18. Un paciente de 56 años presenta una pancreatitis aguda grave, que evoluciona con marcado malestar general, dolor y fiebre alta. Se solicita un TAC al 4° día de hospitalización, visualizándose una imagen compatible con un absceso peripancreático. La conducta más adecuada es:

a. Mantener con tratamiento médico, con régimen cero, analgésicos y alimentación/hidratación endovenosa
b. Mantener tratamiento médico y agregar antibióticos de amplio espectro por vía endovenosa

c. Mantener tratamiento médico, agregar antibióticos endovenosos e iniciar alimentación por sonda nasoenteral

d. Realizar drenaje por punción del absceso, sin necesidad de antibióticos

e. Iniciar antibióticos endovenosos de amplio espectro y realizar drenaje quirúrgico

Respuesta correcta: e. Iniciar antibióticos endovenosos de amplio espectro y realizar drenaje quirúrgico

Explicación: Por tener un absceso, requiere de tratamiento quirúrgico y también de antibióticos. Recordar que, por regla general, las pancreatitis no reciben ATB ni se operan, a menos que estén infectadas. Los abscesos se suelen formar principalmente por pseudoquistes que se infectan (recordar que si no está complicado ni tiene síntomas, el pseudoquiste se observa; en cambio, si se complica o tiene síntomas, se opera). También pueden abscedarse las necrosis infectadas.

Fuente: Cirugía, cuestionario 8.4, P1

19. Una paciente de 60 años, sin antecedentes de importancia, se realiza una ecografía abdominal, que es informada como colecistitis crónica de tipo "vesícula en porcelana". ¿Cuál es el principal riesgo asociado a esta patología?

a. Mayor riesgo de cáncer de vesícula

b. Mayor riesgo de hidatidosis hepática

c. Mayor riesgo de colecistitis aguda

d. Mayor riesgo de coledocolitiasis

e. Mayor riesgo de pancreatitis aguda

Respuesta correcta: a. Mayor riesgo de cáncer de vesícula

Explicación: La vesícula en porcelana y la vesícula escleroatrófica son dos tipos de colecistitis crónicas, que tienen alto riesgo de cáncer de vesícula, por lo que debe realizarse una celecistectomía laparoscópica electiva. Se diagnostican con ecografía.

Fuente: Cirugía, cuestionario 8.4, P3

20. Un paciente de 70 años, diabético, en tratamiento con metformina y glibenclamida, consulta por astenia, baja de peso de 5 meses de evolución. Además, se agrega ictericia y coluria hace 1 mes, sin otros síntomas. Al examen físico se aprecia ictericia franca de escleras y piel, sin otras alteraciones. La ecografía abdominal demuestra dilatación del colédoco y de la vía biliar intrahepática, sin otras alteraciones evidentes. El diagnóstico más probable es:

a. Cáncer de páncreas

b. Pancreatitis crónicas

c. Angina mesentérica

d. Cáncer de vesícula biliar

e. Coledocolitiasis

Respuesta correcta: a. Cáncer de páncreas

Explicación: La diabetes es factor de riesgo de cáncer de páncreas. La clínica suele ser 1. ictericia, 2. dolor abdominal sordo, 3. baja de peso, 4. en ocasiones diabetes y depresión. Lo que manda en este caso es la ictericia silente, por lo que parece cáncer (ictericia sin dolor: por lo que no es una coledocolitiasis). Al haber dilatación del colédoco, es cáncer de páncreas lo sospechado y no el cáncer de vesícula. El examen de elección para su evaluación es la TAC con contraste de abdomen. Sin embargo, en los casos en que hay ictericia, el primer examen suele ser la ecografía.

Fuente: Cirugía, cuestionario 8.4, P6

Hernias de la pared abdominal (5)

21. Un paciente de 35 años consulta por aumento de volumen inguinal izquierdo, de seis meses de evolución, que no ha presentado dolor ni otros síntomas. Al examen físico se aprecia el aumento de volumen inguinal, de consistencia blanda, sin dolor a la palpación, que es posible reducirlo sin problemas, pero quien se reproduce inmediatamente al soltarlo. La conducta adecuada es:

a. solicitar ecografía abdominal
b. solicitar tac de abdomen y pelvis
c. observar evolución
d. programar cirugía electiva
e. resolver quirúrgicamente de manera urgente

Respuesta correcta: d. programar cirugía electiva

Explicación: Tiene una hernia no complicada, por lo que se trata con cirugía electiva (hernioplastía). - Si hubiese tenido complicación (ej. Hernia encarcerada), debería operarse de urgencia. - La excepción es la hernia umbilical asintomática, no complicada y pequeña, que puede observarse tanto en niños como en adultos.

Fuente: Cirugía, cuestionario 8.1, P17

22. Una paciente de 32 años se realiza una herniorrafía con malla, de manera electiva, por padecer de una hernia femoral. ¿Requiere de antibióticos?

a. No, los antibióticos no son necesarios
b. Sí, requiere profilaxis antibiótica durante la cirugía
c. Sí, requiere profilaxis antibióticas durante el día de la cirugía y los 3 días siguientes
d. Sí, requiere profilaxis antibióticas durante el día de la cirugía y los 7 días siguientes
e. Sí, requiere profilaxis antibióticas durante los 3 días previos a la cirugía y los 7 días siguientes

Respuesta correcta: a. No, los antibióticos no son necesarios

Explicación: La herniorrafía es una herida limpia, ya que no abre ninguna mucosa (sí abre el peritoneo, pero es una serosa). Las heridas limpias no requieren antibióticos. Sin embargo, vale la pena aclarar que hay quienes sí recomiendan indicarlos (ej. el mismo UpToDate los recomienda, reconociendo que no existe evidencia para su uso). - Las heridas limpias-contaminadas (abren mucosas) y las heridas contaminadas (cortan tejido inflamado o pierden la técnica aséptica) sí requieren antibióticos profilácticos, pero solo durante la cirugía. - Las heridas sucias o infectadas (contacto con pus, con deposiciones o con signos clínicos de infección) requieren antibióticos como tratamiento. * En las heridas limpias, existen algunas excepciones en las que sí se recomienda el uso de antibióticos (con cefazolina, ya que se infectan con Staphilococcus aures y coagulasa negativo): - Cardíacas en las que se implantan prótesis o dispositivos (marcapasos, stent coronario). También by-pass coronario. - Vasculares en las que se implantan prótesis, abren aorta abdominal o se accede por vía inguinal. - Traumatológicas en las que se implanta prótesis articulares, en toda fractura de cadera, amputación de extremidad por isquemia, cirugía espinal. - Mama: Cáncer de mama (mastectomía, disección ganglionar). - Tórax: toracotomía (aunque no llegue al pulmón) - Neuroquirúrgica: craneotomía (con o sin apertura de meninges), implante de dispositivos (ej. válvula de derivación de LCR).

Fuente: Cirugía, cuestionario 8.2, P18

23. Un paciente de 54 años presenta una hernia incisional pequeña en la zona media infraumbilical, que en las últimas horas de ha vuelto dolorosa, con mayor tamaño e imposible de reducir. El diagnóstico más probable es:

a. Obstrucción intestinal
b. Hernia estrangulada
c. Evisceración
d. Hernia encarcerada
e. Perforación de la hernia

Respuesta correcta: d. Hernia encarcerada

Explicación: - La hernia encarcerada o atascada se caracteriza por ser dolorosa e irreductible, como en este caso. Lo primero es intentar su reducción manual. Si es imposible, se procede a la cirugía de urgencia. - La estrangulada es la que además de atascarse, tiene compromiso vascular, lo que se ve como cambios en la coloración del saco herniario o signos peritoneales. - La perforación se presenta como una peritonitis severa. - La evisceración es una complicación de las cirugías, en que el contenido abdominal protruye, sin un saco peritoneal que lo recubra, a diferencia de la eventración o hernia incisional, que sí tiene un saco peritoneal. * Las hernias complicadas requieres resolución quirúrgica urgente, a diferencia de las no complicadas, que requieren cirugía electiva.

Fuente: Cirugía, cuestionario 8.2, P20

24. Un paciente de 38 años es operado de apendicitis aguda, con buena evolución. Usted lo controla un año después, objetivando la presencia de una hernia incisional, de cerca de 5 cm de diámetro, con un anillo pequeño, en relación a la cicatriz de McBurney. La conducta más adecuada es:

a. Programar cirugía electiva
b. Realizar cirugía de urgencia
c. Observar evolución, sin necesidad de ningún examen ni tratamiento
d. Indicar ejercicios de fortalecimiento de la musculatura abdominal
e. Realizar ecografía de la pared abdominal

Respuesta correcta: a. Programar cirugía electiva

Explicación: Casi todas las hernias se deben operar. Si no están complicadas, requieren una hernioplastía electiva. Si están complicadas, debe ser una hernioplastía de urgencia. - La principal excepción es la hernia umbilical asintomática, que se debe observar tanto en adultos como en niños (no confundir con una hernia inguinal en un niño, que sí se debe operar). La otra excepción es el caso en el que el paciente no quiere operarse.

Fuente: Cirugía, cuestionario 8.3, P12

25. La hernia estrangulada se diferencia de la hernia atascada, en que la primera presenta:

a. Obstrucción intestinal
b. Dolor
c. Imposibilidad de ser reducida
d. Presencia de saco peritoneal
e. Compromiso vascular

Respuesta correcta: e. Compromiso vascular

Explicación: Tanto atascada, como estrangulada presentan dolor, son irreductibles y tienen saco peritoneal. Ambas pueden o no tener obstrucción intestinal asociada (es una complicación distinta). Solo la estrangulada tiene compromiso vascular y es lo que la caracteriza. Ambas requieren cirugía de urgencia.

Fuente: Cirugía, cuestionario 8.4, P9

Patología colorrectal y anorrectal (7)

26. Un paciente de 68 años presenta constipación de dos meses de evolución, asociada a anemia ferropénica. Se solicita una colonoscopía, que muestra un tumor de 6 cm de diámetro en el colon sigmoides, el que es biopsiado, mostrando un adenocarcinoma invasor de diferenciación intermedia. La conducta más adecuada es:

a. Solicitar TAC de abdomen y pelvis y tórax como etapificación
b. Solicitar ecografía abdominal
c. Realizar quimioterapia
d. Solicitar PET-TC de abdomen y tórax
e. Realizar resección del tumor mediante colonoscopía

Respuesta correcta: a. Solicitar TAC de abdomen y pelvis y tórax como etapificación

Explicación: Acaban de diagnosticar un cáncer de colon. Por tanto, debe etapificarse con una TAC de abdomen y una radiografía o TAC de tórax. El PET-TC no aporta mayor información, salvo casos excepcionales. Luego se hará la hemicolectomía izquierda (por estar en el sigmoides), ya que la cirugía es el tratamiento más importante del cáncer de colon. Si la etapificación imagenológica o postquirúrgica muestran compromiso linfático o invasión transmural muy importante, se deberá hacer, además, quimioterapia. La radioterapia no se usa mucho en el cáncer de colon, aunque algo de evidencia tiene (sí se usa en el cáncer de recto y en el de esófago).

Fuente: Cirugía, cuestionario 8.1, P13

27. Un paciente de 55 años, diabético, consulta por dolor anal de un día de evolución. Al examen físico, se aprecia aumento de volumen perianales izquierdo, de 5 cm de diámetro, con eritema de la piel que lo recubre. A la palpación es de consistencia blanda. La conducta más adecuada es:

a. indicar baños de asiento y medidas generales
b. realizar trombectomía en el box
c. realizar drenaje quirúrgico en pabellón
d. indicar dieta rica en fibra y controlar ambulatoriamente
e. indicar antibióticos orales, asociados a laxantes y controlar ambulatoriamente

Respuesta correcta: c. realizar drenaje quirúrgico en pabellón

Explicación: La clínica es de un absceso perianal, que debe ser drenado en pabellón. Se suele dejar antibióticos (ej. ciprofloxacino más metronidazol), aunque su evidencia es escasa. El diagnóstico es clínico (solo se hace con imágenes cuando es interno y no se ve en el examen físico).

Fuente: Cirugía, cuestionario 8.1, P19

28. Un paciente de 36 años, obeso, consulta por dolor anal de dos días de evolución, que ha ido en aumento. Al examen físico se aprecia una zona aumentada de volumen, con eritema de la piel sobre ella, de consistencia blanda y fluctuante, que abarca la zona perianal izquierda. La conducta más adecuada es:

a. Indicar baños de asiento
b. Realizar drenaje quirúrgico

c. Realizar esfinetrotomía de esfínter anal interno

d. Indicar laxante y baños de asiento

e. Realizar trombectomía

Respuesta correcta: b. Realizar drenaje quirúrgico

Explicación: El diagnóstico es un absceso perianal, que se trata con drenaje quirúrgico (suelen indicarse antibióticos, además, pero no tienen evidencia muy fuerte). Los baños de asiento son el tratamiento del hemorroide trombosado y de la fisura anal. Los laxantes también se indican en la fisura anal.

Fuente: Cirugía, cuestionario 8.2, P15

29. Una paciente de 63 años ha presentado dos episodios de diverticulitis aguda de colon sigmoides. El primero fue tratado de manera ambulatoria, mientras que el segundo requirió hospitalización, por tener un pequeño absceso pericólico, que fue drenado por punción guiada por ecografía. Actualmente está en buenas condiciones, asintomática. La conducta más adecuada es:

a. Indicar dieta rica en fibra y controlar ambulatoriamente

b. Solicitar TAC de abdomen y pelvis y decidir manejo según hallazgos

c. Realizar angiografía mesentérica

d. Aconsejar cirugía electiva de resección del segmento con divertículos y anastomosis primaria

e. Realizar cirugía de Hartmann

Respuesta correcta: d. Aconsejar cirugía electiva de resección del segmento con divertículos y anastomosis primaria

Explicación: El antecedente de 2 diverticulitis agudas, tratadas adecuadamente, obliga a recomendar la resección segmentaria, con anastomosis primaria, ya que es muy probable que recurra. La importancia de esto radica en que una diverticulitis grave, complicada con peritonitis difusa o estercorácea (Hinchey III y IV) se deben tratar con cirugía de Hartmann, lo que implica dejar al paciente con una colostomía por varios meses (no se puede hacer anastomosis primaria en un colon no preparado). En cambio, en este caso, se puede hacer una preparación de colon, con una colectomía segmentaria electiva, con menor morbimortalidad. manejo se puede resumir de la siguiente forma: - Hinchey I (solo edema o absceso pequeño): Ambulatorio con antibióticos orales (poca o nula evidencia, pero se deja ciprofloxacino + metronidazol) y analgésicos. - Hinchey II (absceso distante o desde 5 cm): Drenaje percutáneo. ATB endovenosos (ej. ceftriaxona + metronidazol, aunque hay muchos esquemas útiles). - Hinchey III (peritonitis difusa): Cirugía de Hartmann (aceptable intentar anastomosis primaria) - Hinchey IV (peritonitis estercorácea): Cirugía de Hartmann. - Cirugía diferida si 2 episodios leves o 1 episodio complicado.

Fuente: Cirugía, cuestionario 8.2, P16

30. Un paciente de 70 años presenta dolor abdominal bajo, asociado a fiebre. El dolor es de carácter sordo, constante y se ubica preferentemente en la FII. Al examen físico presenta dolor en dicha zona, sin signos peritoneales. Se solicita un TAC de abdomen y pelvis, que visualiza una imagen sugestiva de diverticulitis aguda del colon sigmoides, con formación de un absceso pericólico de 2,0 cm de diámetro. La conducta más adecuada es:

a. Iniciar régimen hídrico e indicar ciprofloxacino + metronidazol por vía oral

b. Hospitalizar, iniciar ceftriaxona + metronidazol por vía endovenosa y realizar drenaje percutáneo del absceso

c. Hospitalizar e iniciar ceftriaxona + metronidazol por vía endovenosa y realizar drenaje del absceso por vía colonoscópica

d. Hospitalizar y realizar resección del segmento comprometido, con anastomosis primaria, bajo cobertura antibiótica

e. Hospitalizar y realizar cirugía de Hartmann, bajo cobertura antibiótica

Respuesta correcta: a. Iniciar régimen hídrico e indicar ciprofloxacino + metronidazol por vía oral

Explicación: Tiene una diverticulitis Hinchey I (solo inflamación o absceso pericólico < 5 cm), la que se trata con analgésicos, antibióticos orales (no tienen evidencia, pero se usa ciprofloxacino + metronidazol) y régimen hídrico. - La diverticulitis Hinchey II (absceso a distancia o ≥5 cm) se trata con antibióticos endovenosos, más drenaje por punción, guiada por TAC o ecografía. - Las diverticulitis Hinchey III (peritonitis difusa) y Hinchey IV (peritonitis estercorácea) se tratan con cirugía de Hartmann (aunque en la Hinchey III es aceptable, en casos seleccionados, hacer una anastomosis primaria con o sin colostomía de seguridad).

Fuente: Cirugía, cuestionario 8.3, P3

31. Un paciente presenta dolor anal, que inició hace 24 horas mientras trabajaba y que ha aumentado de manera importante, en especial al defecar. Al examen físico se aprecia aumento de volumen blando y eritema en la zona perianal derecha, doloroso a la palpación. El diagnóstico más probable es:

a. Fisura anal

b. Fluxión hemorroidal

c. Hemorroide externo trombosado

d. Absceso perianal

e. Fístula perianal

Respuesta correcta: d. Absceso perianal

Explicación: Es un absceso perianal clásico

Fuente: Cirugía, cuestionario 8.3, P15

32. Un paciente de 60 años consulta por dolor anal muy intenso, que inició hace algunas horas, luego de un cuadro de constipación. Al examen físico se aprecia una masa violácea, que protruye a través del ano, imposible de reducir y que es muy dolorosa. El diagnóstico más probable es:

a. Absceso perianal

b. Hemorroide externo trombosado

c. Prolapso hemorroidal grado 4

d. Fluxión hemorroidal

e. Cáncer de recto

Respuesta correcta: d. Fluxión hemorroidal

Explicación: Se ve la masa que protruye a través del ano y que es dolorosa, lo que es propio de la fluxión. Su diagnóstico es clínico y su tratamiento suele ser médico, con baños de asiento y analgésicos. Solo en algunos casos seleccionados, además, requiere cirugía. - No es un hemorroide externo, porque viene desde dentro del ano. - No es un prolapso hemorroidal grado 4 (que también es irreductible), porque está con mucho dolor y por tanto está complicado con una fluxión. - Tanto los hemorroides internos prolapsados grado II, III y IV pueden fluxionarse, por lo que no se puede saber qué grado son en este caso. Lo más característico es que la fluxión ocurra después un parto vaginal, un periodo de constipación o de maniobra de Valsalva.

Fuente: Cirugía, cuestionario 8.4, P17

Trauma (6)

33. Un paciente de 70 años sufre una caída de altura, golpeándose la cabeza. Presenta importante dolor y vómitos en 6 oportunidades. Al examen físico está consciente y orientado, sin signos neurológicos focales. La conducta más adecuada es:

a. solicitar radiografía de cráneo
b. solicitar TAC de cráneo sin contraste
c. solicitar RMN de cráneo con contraste
d. administrar analgésicos endovenosos y reevaluar en seis horas
e. indicar analgésicos orales y enviar a domicilio, indicando reconsultar en caso de aparición de signos de alarma

Respuesta correcta: b. solicitar TAC de cráneo sin contraste

Explicación: Tiene 2 razones para hacer el TAC: 1. Tiene más de 65 años, por lo que hay riesgo de hematoma subdural y 2. Tiene dolor intenso más vómitos, lo que es sospechoso de HTEC (hipertensión endocraneana). El TEC con signos de alarma, se debe estudiar con TAC de cerebro sin contraste. Indicaciones para hacer una TAC en TEC: - Glasgow < 15. - Examen neurológico alterado. - Sospecha de fractura de cráneo (ej. signo de mapache, signo de Battle, otorraquia, rinorraquia, depresión craneal). - Edad mayor a 60 – 65 años (según la fuente varía). - Amnesia mayor a 30 minutos. - Intoxicación alcohólica o por otros fármacos que impidan una adecuada evaluación. - Dolor de cabeza intenso o que aumenta. - Vómitos reiterados (algunas fuentes utilizan 2 episodios, otras 3). - Mecanismo de alta energía (ej. atropello, caída de 1 metro o más). - Convulsiones. - Riesgo de hemorragia (anticoagulantes, alteraciones de la hemostasia). - Edad menor a 2 años es discutible: guías actuales prefieren no hacer la TAC en mayores de 3 meses con examen absolutamente normal (ej. sin chichón siquiera, en los que no se sospecha maltrato ni tuvo compromiso de conciencia de segundos siquiera).

Fuente: Cirugía, cuestionario 8.1, P6

34. Un paciente es apuñalado en el tórax, evolucionando con dificultad respiratoria. Examen físico, se observa una herida cortante en relación a la parrilla costal derecha, con escaso sangrado. Se solicita una radiografía de tórax, que muestra derrame pleural moderado. La más adecuada es:

a. realizar toracotomía de urgencia
b. realizar videotoracoscopía
c. instalar un tubo pleural con trampa de agua
d. realizar pericardiocentesis
e. observar evolución y realizar control con radiografía en cuatro a seis horas

Respuesta correcta: c. instalar un tubo pleural con trampa de agua

Explicación: Tiene un derrame pleural, más un antecedente de herida con arma blanca. Por tanto, se debe sospechar un hemotórax, que se trata con un tubo pleural. Solo si tiene mucho flujo (más de 1,5 litros en total o 200 cc/h), es decir, si es masivo, se opera. Sin embargo, algunos utilizan otros puntos de corte (ej. 1 litro para masivo). Como comentario previo, el manejo de la herida torácica por arma blanca incluye el ABC (neumotórax a tensión y taponamiento cardíaco van antes que la vía aérea) y luego se estudian con radiografía de tórax (idealmente más una ecografía FAST de tórax).

Fuente: Cirugía, cuestionario 8.1, P11

35. Un paciente de 50 años sufre un accidente de tránsito, golpeándose el tórax contra el volante. Evoluciona con disnea, asociada a signos sugerentes de un derrame pleural, el que se constata mediante

radiografía de tórax. Se Instala un tubo pleural, dando salida a cerca de un litro de sangre. Usted lo evalúa 4 horas después, constando que desde que se instaló el tubo, ha dado un litro adicional. La conducta más adecuada es:

a. Retirar el tubo pleural y administrar suero fisiológico endovenoso
b. Administrar suero fisiológico endovenoso y realizar lavado pleural
c. Administrar suero fisiológico y administrar sellante pleural a través del tubo
d. Administrar suero fisiológico y transfundir glóbulos rojos
e. Administrar suero fisiológico y realizar cirugía de manera urgente

Respuesta correcta: e. Administrar suero fisiológico y realizar cirugía de manera urgente

Explicación: Tiene un hemotórax masivo, que se trata con cirugía (en cambio, el hemotórax no masivo, solo se trata con el tubo). El hemotórax masivo se define como aquel que en total drena más de 1,5 litros o más de 200 cc por hora (por 2 horas), aunque hay quienes ponen un punto de corte más bajo (ej. 1 litro).

Fuente: Cirugía, cuestionario 8.2, P3

36. Un paciente de 70 años sufre un atropello por una motocicleta, golpeándose la cabeza contra el suelo. Inicialmente está bien, aunque 6 horas después inicia con cefalea, que va en aumento, siguiéndose, 5 horas más tarde, de desorientación y sopor. El diagnóstico más probable es:

a. Hemorragia subaracnoidea traumática
b. Hematoma epidural
c. Hematoma subdural
d. Contusión cerebral
e. Hematoma intraparenquimatoso

Respuesta correcta: c. Hematoma subdural

Explicación: Es un hematoma subdural clásico: adulto mayor con TEC severo, que evoluciona con un síndrome de hipertensión endocraneana (vómitos y cefalea, más compromiso de conciencia). Además, es característico el intervalo lúcido de varias horas. El hematoma epidural o extradural suele afectar a personas más jóvenes y tiene intervalo lúcido breve, de solo minutos o escasas horas. Se debe realizar una TAC de cerebro, sin contraste para confirmar el diagnóstico. El tratamiento suele ser el drenaje quirúrgico, más el manejo general del TEC severo (medidas de neuroprotección, etc.).

Fuente: Cirugía, cuestionario 8.2, P17

37. Un paciente sufre un asalto, recibiendo un impacto de baja en el abdomen. Evoluciona con hipotensión arterial, por lo que recibe suero fisiológico endovenoso. La conducta más adecuada es:

a. Realizar laparotomía exploradora de urgencia
b. Realizar transfusión de glóbulos rojos
c. Solicitar ecografía abdominal
d. Solicitar TAC abdominal
e. Realizar compresión abdominal

Respuesta correcta: a. Realizar laparotomía exploradora de urgencia

Explicación: En el trauma abdominal, tanto la etiología por armas de fuego, como el compromiso hemodinámico, son indicación de exploración quirúrgica. Las otras indicaciones son: signos peritoneales, líquido libre abdominal en la ecografía (sangre) y la herida por arma blanca que llega al peritoneo o

aponeurosis muscular. Las heridas por arma de fuego, además, se deben tratar con ABC, reposición de fluidos, antibióticos de amplio espectro, TAC para identificar el trayecto de la bala. En centros de baja complejidad, se debe derivar de inmediato.

Fuente: Cirugía, cuestionario 8.3, P5

38. Un paciente de 30 años sufre un accidente de tránsito, mientras manejaba una motocicleta, sin usar casco, golpeándose la cabeza contra el pavimento. Inicialmente está consciente, con cefalea importante, pero 20 minutos después evoluciona con compromiso de consciencia. Al examen físico se aprecian signos de enclavamiento del uncus del temporal (anisocoria). El diagnóstico de sospecha es:

a. Contusión cerebral
b. Fractura de la base de cráneo
c. Hemorragia subaracnoidea
d. Hematoma subdural
e. Hematoma epidural

Respuesta correcta: e. Hematoma epidural

Explicación: Es una hematoma epidural o extradural clásico, con un TEC que evoluciona a los pocos minutos u horas (intervalo lúcido corto o ausente, porque su causa es sangramiento arterial, de la arteria meníngea media) con un cuadro de hipertensión endocraneana y compromiso de conciencia. El hematoma subdural (HSD), en cambio, suele afectar a adultos mayores y tiene un intervalo lúcido más largo, porque es causado por sangramiento venoso. Ambos se manejan quirúrgicamente, más el manejo del TEC severo (la excepción es el HSD pequeño, estable y sin compromiso neurológico). Sin embargo, es importante aclarar que, en la práctica, la clínica no permite diferenciar bien las distintas complicaciones del TEC severo, por lo que siempre se debe solicitar una TAC de cerebro que las identifique.

Fuente: Cirugía, cuestionario 8.3, P8

Cirugía torácica (6)

39. Un paciente de 18 años consulta por dolor torácico, de inicio súbito, que inició hace dos horas y presenta tope inspiratorio. Al examen físico, se aprecia y hipersonoridad del hemitórax derecho, asociado a disminución marcada del murmullo pulmonar. Se solicita una radiografía de tórax, que muestra un neumotórax derecho de tamaño de 30% aproximadamente. La más adecuada es:

a. Administrar analgésicos endovenosos y controlar con una nueva radiografía de tórax en cuatro a seis horas
b. instalar un tubo pleural con trampa de agua
c. puncionar el segundo espacio intercostal, de manera urgente
d. Realizar videotoracoscopía
e. realizar toracotomía abierta

Respuesta correcta: b. instalar un tubo pleural con trampa de agua

Explicación: Tiene un neumotórax espontáneo mayor a 15%, que se tratan con drenaje del aire, a través de una sonda o con una toracostomía (o tubo pleural). - Si hubiese sido menor a 15%, lo más correcto hubiese sido dar analgésicos y controlar con nueva radiografía en 4 a 6 horas. Si se mantiene estable, se observa. Si crece, se maneja como si fuera mayor a 15%. - Si hubiese sido recurrente (el segundo episodio), estaría indicada la cirugía (que hoy se prefiere hacer por videotoracoscopía, si es que está disponible. Si no, por toractomía). - Si hubiese sido a tensión (clínica de hipotensión, ingurgitación yugular y asimetría torácica), estaría indicada la punción del segundo espacio intercostal en la LMC (línea

medioclavicular) o del quinto espacio intercostal en la LAM (línea axilar media), como primera medida. Eso sí, si es posible hacer inmediatamente la toracostomía, pues es aceptable hacerla, sin necesidad de puncionar.

Fuente: Cirugía, cuestionario 8.1, P15

40. Un paciente de 65 años, fumador, sin otros antecedentes de importancia, presenta un cuadro de 4 meses de evolución de disnea de esfuerzos y tos ocasional, con expectoración mucosa, que en varias ocasiones ha presentado estrías de sangre. El examen físico no aporta mayor información. El diagnóstico más probable es:

a. Bronquiectasias
b. Absceso pulmonar
c. Hidatidosis pulmonar
d. Cáncer de pulmón
e. Tromboembolismo pulmonar crónico

Respuesta correcta: d. Cáncer de pulmón

Explicación: Es un cáncer clásico: antecedente de fumar, más cuadro de tos, disnea y hemoptisis. Además, suele tener acropaquías, baja de peso y síndromes paraneoplásicos. El examen pulmonar suele ser normal o tener alteraciones inespecíficas.

Fuente: Cirugía, cuestionario 8.2, P14

41. Un paciente de 23 años sufrió un neumotórax espontáneo del 15%, que fue manejado con observación, con buena evolución. Seis meses después, presenta un cuadro de dolor torácico con tope inspiratorio, por lo que se solicita una radiografía de tórax, que demuestra un neumotórax ipsilateral del 30%. La conducta más adecuada es:

a. Indicar analgésicos y observar evolución, controlando con nueva radiografía a las 4-6 horas
b. Puncionar el segundo espacio intercostal
c. Instalar un tubo pleural con trampa de agua
d. Realizar aspiración del neumotórax con una jeringa
e. Resolver quirúrgicamente

Respuesta correcta: e. Resolver quirúrgicamente

Explicación: El neumotórax recurrente se trata con cirugía, independiente del tamaño. Se prefiere la cirugía por videotoracoscopía. - El primer episodio de neumotórax se trata con un tubo pleural (opción C) o otra opción de drenaje (ej. sonda), si es mayor a 15%. Si es menor a 15%, se maneja con analgesia, conducta expectante y control radiográfico en 4-6 horas (opción A). - El neumotórax a tensión, es decir, el que tiene hipotensión e ingurgitación yugular, se maneja con punción del segundo espacio intercostal en la LMC (opción B) y luego se instala el tubo pleural. También se puede puncionar el quinto espacio intercostal en la LAM (línea axilar media) y, si es posible hacer inmediatamente la toracostomía, pues es aceptable hacerla, sin necesidad de puncionar.

Fuente: Cirugía, cuestionario 8.3, P4

42. Ante la sospecha clínica de bronquiectasias, ¿qué examen es más adecuado para confirmar el diagnóstico?

a. Broncoscopía
b. Radiografía de tórax

c. CIntigrafía
d. TAC de tórax
e. Resonancia magnética de tórax

Respuesta correcta: d. TAC de tórax

Explicación: Las bronquiectasias se diagnostican con el TAC de tórax, idealmente de cortes finos. Son incurables, así que el tratamiento es simplemente el drenaje de las secreciones, con kinesioterapia respiratoria y manejo antibiótico de las exacerbaciones. Solo si están localizadas, se pueden resecar quirúrgicamente. Como última opción, está el trasplante pulmonar. Si se complican con hemoptisis, se debe manejar con broncoscopía urgente y, en los casos masivos, muchas veces termina en embolización o cirugía de urgencia.

Fuente: Cirugía, cuestionario 8.3, P14

43. El neumotórax a tensión presenta todo lo siguiente excepto:

a. Ingurgitación yugular
b. Desviación de la tráquea hacia contralateral
c. Hipertensión arterial
d. Taquicardia
e. Asimetría torácica

Respuesta correcta: c. Hipertensión arterial

Explicación: Tiene todo lo mostrado ahí, pero con hipotensión, no con hipertensión. Sí hay hipertensión torácica, pero no arterial.

Fuente: Cirugía, cuestionario 8.4, P16

44. Un paciente de 40 años, con antecedente de tuberculosis tratada, hace 3 años, presenta broncorrea crónica desde entonces, con exacerbaciones en algunas oportunidades, las que trata con antibióticos. Además, ha presentado hemoptisis en 3 oportunidades y sus baciloscopías de control han resultado negativas. El diagnóstico más probable es:

a. Cáncer de pulmón
b. Tuberculosis pleural
c. Tromboembolismo pulmonar crónico
d. Atelectasias
e. Bronquiectasias

Respuesta correcta: e. Bronquiectasias

Explicación: El antecedente de TBC y luego la clínica de broncorrea matinal y hemoptisis sugieren bronquiectasias (dilatación irreversible de los bronquios). Se debe estudiar con TAC de tórax de cortes finos o cortes múltiples. Se tratan con tratamiento médico: drenaje postural, antibióticos en las exacerbaciones (que suelen ser por infecciones bacterianas), pero son irreversibles, por lo que, si se complican muy frecuentemente solo queda la opción de removerlas quirúrgicamente si están localizadas; u optar por el trasplante pulmonar, si son difusas (drenaje postural y mucolíticos).

Fuente: Cirugía, cuestionario 8.4, P20

Cirugía vascular (9)

45. Una paciente de 67 años presenta un accidente vascular encefálico, de tipo en embólico, razón por la cual se decide solicitar una ecografía carotidea, que demuestra una estenosis del 60% en la carótida izquierda, sin estenosis del lado derecho. La conducta más adecuada es:

a. realizar endarterectomía carotidea izquierda
b. realizar endarterectomía carotidea bilateral
c. indicar anticoagulación oral a permanencia
d. indicar aspirina oral a permanencia
e. realizar endarterectomía carotidea izquierda e indicar anticoagulación oral a permanencia

Respuesta correcta: a. realizar endarterectomía carotidea izquierda

Explicación: Tiene una estenosis mayor a 50% (significativa), las que se operan si es que 1. son mayores al 70% (no es el caso) o 2. si es que vienen con síntomas (AVE o TIA; este es el caso). En el lado derecho, por no haber obstrucción (o también si hubiese una menor a 50%), no se debe operar. La anticoagulación a permanencia solo se indica en causas persistentes de AVE o TIA, como por ejemplo una fibrilación auricular crónica. Los antiagregantes a permanencia sí están indicados, al igual que las estatinas y el agresivo manejo de todos sus factores de riesgo cardiovascular. Sin embargo, lo que se pregunta es el manejo específico de la estenosis carotídea sintomática, mayor a 50%, que es quirúrgico.

Fuente: Cirugía, cuestionario 8.1, P8

46. Un paciente de 69 años, muy fumador, presenta dolor en las pantorrillas que aparece al caminar 100 metros y que se hace insoportable a los 200 metros, por lo que debe detenerse. Al examen físico presenta disminución de los pulsos pedios, sin otras alteraciones. Además de dejar de fumar y controlar los factores de riesgo cardiovascular, la conducta más adecuada es:

a. Solicitar angiografía
b. Anticoagular con heparina y realizar endarterectomía
c. Realizar by pass
d. Indicar ejercicios de caminata e iniciar aspirina
e. Indicar anticoagulación con TACO

Respuesta correcta: d. Indicar ejercicios de caminata e iniciar aspirina

Explicación: Es una claudicación intermitente, sin signos de isquemia crítica (índice tobillo/brazo menor a 0,5, úlcera arterial o dolor de reposo). Por tanto, debe ser manejada con control de sus factores de riesgo cardiovascular, más un programa de ejercicios, que le permita mejorar su tolerancia al ejercicio (induce la formación de colaterales). * Actualmente la prueba más importante en la enfermedad arterial periférica es el simple índice tobillo brazo, que si está menor a 0,9 confirma el diagnóstico de enfermedad arterial periférica y, si es de 0,4 o menos, es compatible con isquemia crítica, que requiere revascularización. * Los registros de volumen de pulso (PVR), como la pletismografía todavía se pueden usar y no es obligatorio usarlos solo en pacientes con isquemia crítica, ya que también entregan información útil en pacientes con isquemia no crítica, como en este caso. * Por regla general no es necesario realizar una angiografía o un angioTAC en la isquemia crónica, salvo que ya se haya decidido que se resolverá con revascularización quirúrgica, ya que sirve para determinar algunos aspectos prácticos de la cirugía. En cambio, en la isquemia aguda suelen ser muy útiles (a pesar de que la clínica y la revascularización urgente siguen siendo lo más importante). Si hubiese tenido criterios de isquemia crítica, la respuesta habría sido derivar para cirugía de revascularización, realizando previamente las pruebas correspondientes (PVR, angiografía o angioTAC).

Fuente: Cirugía, cuestionario 8.2, P6

47. Un paciente asintomático consulta porque palpa un latido en la zona supraumbilical. Al examen físico presenta una masa pulsátil, indolora, que no se moviliza con la respiración. Se solicita un TAC de abdomen y pelvis, que visualiza un aneurisma de la aorta abdominal de 6,2 cm de diámetro, ubicado a la altura de las arterias renales. La conducta más adecuada es:

a. Iniciar aspirina, atorvastatina, clopidogrel y controlar con ecografías abdominales periódicas
b. Iniciar anticoagulación a permanencia y controlar con ecografías periódicas
c. Solicitar angioTAC de inmediato
d. Resolver quirúrgicamente
e. Observar evolución, sin necesidad de estudio ni tratamiento adicional

Respuesta correcta: d. Resolver quirúrgicamente

Explicación: Tiene un aneurisma aórtico abdominal no complicado. El diámetro determina el tratamiento. Si tiene menos de 5 cm, se observa, más el manejo de los factores de riesgo cardiovascular. Desde 5 o 5, 5 cm de diámetro (varía según la fuente), como en este caso, se debe resolver quirúrgicamente, con un stent (idealmente) o con una prótesis de reemplazo aórtico. Si tiene 8 cm o más, esta cirugía se debe hacer lo antes posible. - Si está roto, se debe reanimar y resolver con cirugía de inmediato, aunque la mayoría muere igual (antes de llegar siquiera al hospital el 50%, pero otro 30-40% muere a pesar de llegar). - El angioTAC es el manejo de la disección aórtica o aneurisma aórtico disecante, que no debe ser confundido con el aneurisma aórtico abdominal.

Fuente: Cirugía, cuestionario 8.2, P12

48. Un paciente de 67 años sufre un accidente isquémico transitorio cerebral, de 15 minutos de duración, recuperándose de inmediato. Al examen físico se ausculta un soplo carotideo izquierdo. ¿Cuál es el mejor examen para proseguir con el estudio?

a. Ecocardiograma
b. Ecografía doppler cervical
c. AngioTAC de cuello
d. AngioRMN de tórax y cuello
e. Angiografía carotidea

Respuesta correcta: b. Ecografía doppler cervical

Explicación: Los soplos carotideos se estudian con ecografía-Doppler de cuello o de carótidas, ya que ve la estenosis carotidea. Vale la pena recordar que tanto los AVE isquémicos, como los AIT (accidente isquémico transitorio) se estudian con eco-Doppler de cuello, ecocardiografía y holter de arritmias, en busca de la fuente embólica.

Fuente: Cirugía, cuestionario 8.2, P21

49. Un paciente de 65 años presenta una úlcera en la extremidad inferior izquierda, levemente dolorosa, ubicada en el maléolo interno. Además, se aprecia hiperpigmentación de la piel circundante. La conducta más adecuada es:

a. Diagnosticar una úlcera arterial y solicitar PVR
b. Diagnosticar una úlcera venosa y realizar safenectomía
c. Diagnosticar una úlcera arterial y solicitar angiografía
d. Diagnosticar una úlcera arterial y realizar by pass femoropoplíteo
e. Diagnosticar una úlcera venosa, realizar curaciones y vendaje compresivo

Respuesta correcta: e. Diagnosticar una úlcera venosa, realizar curaciones y vendaje compresivo

Explicación: Es una úlcera venosa clásica: indolora o poco dolorosa, de color violácea y bordes regulares, con hiperpigmentación de la piel (por depósitos de hemosiderina), habitualmente ubicada en el maléolo medial. Se trata con curaciones y tratamiento compresivo con medias o vendaje, más reposo con pie en alto. El diagnóstico es clínico, aunque, en casos seleccionados se puede solicitar una ecografía doppler para determinar las zonas de insuficiencia valvular o reflujo (ej. venas penetrantes). Solo algunos casos llegan a manejo quirúrgico con ablación de algunas venas superficiales y penetrantes (las que comunican los sistemas venosos superficial y profundo) * La úlcera arterial, en cambio es muy dolorosa, pálida, de bordes irregulares, generalmente en el maléolo lateral, asociada a disminución de los pulsos. Se trata con curaciones y luego cirugía de revascularización, ya que se considera una isquemia crítica.

Fuente: Cirugía, cuestionario 8.3, P1

50. Un paciente de 56 años, hipertenso y diabético, consulta por dolor torácico muy intenso, que empezó hace una hora. Al examen físico se ausculta un RR2T, con un soplo diastólico III/VI en la zona precordial. Su electrocardiograma muestra taquicardia sinusal, con alteraciones inespecíficas de la repolarización. El diagnóstico más probable es:

a. Rotura del tabique interventricular
b. Rotura del músculo papilar
c. Rotura de la pared libre ventricular
d. Disección aórtica
e. Tromboembolismo pulmonar

Respuesta correcta: d. Disección aórtica

Explicación: El soplo diastólico de insuficiencia aórtica sugiere fuertemente una disección, en contexto de dolor torácico (también la asimetría de pulsos). Se estudia con angioTAC de tórax y su tratamiento incluye antihipertensivos endovenosos (ej. bomba de labetalol) más tratamiento quirúrgico en las tipo A (como en este caso en que la presencia de soplo cardíaco muestra que está por sobre la subclavia izquierda) y también en las tipo B que se complican (ej. con obstrucción de alguna arteria como la renal o ilíaca, debido al "flap" de disección). - La rotura del tabique interventricular ocurre en contexto de un infarto y tiene soplo holosistólico, más insuficiencia cardíaca. - La rotura del músculo papilar es igual. - La rotura espontánea de la pared libre ventricular también suele ocurrir en contexto de un infarto, pero tiene clínica de taponamiento. - El tromboembolismo pulmonar suele tener disnea súbita, con dolor torácico súbito, más hemoptisis, fiebre, dolor tipo puntada de costado.

Fuente: Cirugía, cuestionario 8.3, P6

51. Un paciente presenta un cuadro sugerente de un accidente isquémico transitorio, por lo que se realizar estudio de fuente embolica, que no muestra alteraciones, excepto por un ecodoppler cervical, que demuestra una estenosis carotidea derecha del 20%. La conducta más adecuada respecto a este hallazgo es:

a. Mejorar el control de sus factores de riesgo cardiovascular, iniciar aspirina y atorvastatina
b. Mejorar el control de sus factores de riesgo cardiovascular e iniciar anticoagulación a permanencia
c. Solicitar angiografía carotidea y decidir conducta según hallazgos
d. Realizar angioplastia con stent
e. Realizar endarterectomía carotidea

Respuesta correcta: a. Mejorar el control de sus factores de riesgo cardiovascular, iniciar aspirina y atorvastatina

Explicación: Es una pregunta discutible. Tiene una estenosis carotidea no significativa (menor a 50%), por lo que no se debe operar, a pesar de tener un accidente isquémico. Sí es necesario manejar agresivamente los factores de riesgo cardiovascular. - La anticoagulación no está indicada, a menos que haya una causa de base que requiera anticoagularse, como la fibrilación auricular. - Sí se opera con endarterectomía cuando 1. la estenosis es mayor a 70% y 2. la estenosis es mayor a 50% y tiene síntomas (accidentes cerebrovasculares o accidentes isquémicos transitorios).

Fuente: Cirugía, cuestionario 8.3, P16

52. Una paciente de 58 años, sin antecedentes de importancia, presenta dolor de la extremidad inferior derecha, de inicio súbito, que inició hace una hora. Al examen físico se aprecia palidez y frialdad de la pierna derecha, con ausencia de pulsos pedio y tibial posterior. La conducta más adecuada es:

a. Solicitar ecografía-doppler de urgencia
b. Solicitar dímero D de urgencia
c. Solicitar PVR de urgencia
d. Anticoagular con heparina y resolver quirúrgicamente de inmediato
e. Anticoagular con heparina y luego iniciar cumarínicos, por al menos 3 meses

Respuesta correcta: d. Anticoagular con heparina y resolver quirúrgicamente de inmediato

Explicación: Es una embolia aguda de extremidades inferiores, cuyo diagnóstico es clínico (tiene las P: palidez, poiquilotermia, pain, paresia, parestesia y pulso ausente). Se debe anticoagular con heparina EV, luego solicitar una angiografía o un angioTAC de extremidades inferiores (de elección si está disponible) y luego hacer la revascularización de urgencia (embolectomía quirúrgica abierta, embolectomía endovascular o trombólisis, según las características del émbolo).

Fuente: Cirugía, cuestionario 8.4, P2

53. Un paciente de 65 años sufre un accidente vascular isquémico con clínica compatible con afectación de la arteria cerebral media izquierda, que es manejado adecuadamente con trombólisis endovenosa, evolucionando sin secuelas. Luego del alta se solicita un eco-Doppler carotideo que demuestra una estenosis de la carótida izquierda de 60%. La conducta más adecuada es:

a. Solicitar una angiografía carotidea para luego resolver con endarterectomía carotidea
b. Indicar anticoagulación a permanencia
c. Indicar control de sus factores de riesgo cardiovascular, iniciar aspirina y atorvastatina y observar evolución
d. Realizar trombólisis intraarterial
e. Controlar con ecografía carotidea en 6 meses

Respuesta correcta: a. Solicitar una angiografía carotidea para luego resolver con endarterectomía carotidea

Explicación: Tiene una estenosis carotídea significativa (mayor a 50%) y sintomática (AVE), por lo que se debe operar con endarterectomía carotídea. Antes se hace una angiografía, habitualmente por angioresonancia o angioTAC. Sí es correcto controlar los factores de riesgo cardiovascular intensivamente, dando aspirina y estatinas, pero, lo más importante es la cirugía tanto en las estenosis mayores de 70% como en las mayores a 50% con síntomas (AVE o TIA).

Fuente: Cirugía, cuestionario 8.4, P13

Patología cardíaca quirúrgica (7)

54. ¿Cuál de las siguientes es una indicación de tratamiento quirúrgico en un paciente con una estenosis mitral?

a. presencia de soplo diastólico
b. dilatación de la aurícula izquierda
c. disminución de la función ventricular izquierda
d. presencia de síntomas importantes de insuficiencia cardiaca izquierda
e. asociación a insuficiencia valvular leve

Respuesta correcta: d. presencia de síntomas importantes de insuficiencia cardiaca izquierda

Explicación: En resumen, se operan las valvulopatías cardiacas 1. graves y 2. las sintomáticas. La cirugía puede ser una valvuloplastía (si los velos están en buenas condiciones) o un recambio valvular (si los velos valvulares están en muy malas condiciones y ya no son reparables: es lo más frecuente). Además, en caso de que se haga un recambio, se puede hacer con (A) prótesis mecánica (en pacientes jóvenes para que les dure por toda la vida, pero con el problema que requiere anticoagulación con altas dosis de cumarínicos, para llegar a un INR de 2,5 a 3,5) o (B) Prótesis biológica (en pacientes ancianos, dado que estas prótesis duran solo 10 años, pero tienen la ventaja de que no requieren TACO; también se prefiere la prótesis biológica si hay alguna contraindicación del TACO).

Fuente: Cirugía, cuestionario 8.1, P12

55. Paciente de 65 años consulta por dolor torácico, que aparece al caminar tres cuadras y que cede con el reposo. Se solicita un electrocardiograma que resulta normal. La conducta más adecuada es:

a. iniciar aspirina oral y controlar sus factores de riesgo cardiovascular
b. solicitar una ecocardiografía
c. solicitar un test de esfuerzo
d. realizar angioplastía coronaria
e. indicar ejercicio físico regular, controlar los factores de riesgo cardiovascular y controlar ambulatoriamente.

Respuesta correcta: c. solicitar un test de esfuerzo

Explicación: La angina estable se estudia con test de esfuerzo convencional (TE), que es un electrocardiograma durante una caminata. - Eso sí, hay casos en que debo usar un equivalente (ecocardiografía de esfuerzo [conocida como Eco Dobutamina] o con el cintigrama de perfusión miocárdica o cintigrama de esfuerzo [conocida como cintigrama talio dipiridamol]. Estos casos son: BCRI (bloqueo completo de rama izquierda), pacientes amputados, pacientes que no toleran el ejercicio y no pueden hacer el test de esfuerzo. - Si el test de esfuerzo o sus equivalentes están alterados, se hace la coronariografía para determinar la vía de revascularización. - Sí se deben usar aspirina, estatina y todo el manejo intensivo de los factores de riesgo cardiovascular.

Fuente: Cirugía, cuestionario 8.1, P16

56. Paciente de 60 años, cursando un infarto agudo al miocardio de seis días de evolución, presenta marcado deterioro del estado hemodinámico. Al examen físico se auscultan un soplo holosistólico intenso, en todo el precordio. Diagnóstico de sospecha es:

a. disección aórtica
b. rotura del músculo papilar

c. rotura de la pared libre ventricular
d. aneurisma ventricular
e. reinfarto

Respuesta correcta: b. rotura del músculo papilar

Explicación: Deben revisar el resumen de semiología cardíaca, en la parte de las complicaciones mecánicas del infarto. - Tanto la rotura de músculo papilar, como la rotura de tabique interventricular dan soplo holosistólico. - La disección aórtica tiene dolor y soplo diastólico. La rotura de pared libre tiene un taponamiento. - El aneurisma ventricular puede quedar con angina, tener arritmias ventriculares, quedar con un supradesnivel persistente del ST (no es específico, pero se suele enseñar), presentar fenómenos embólicos o incluso presentarse como muerte súbita, aunque la mayoría se ve en la ecografía de control.

Fuente: Cirugía, cuestionario 8.1, P20

57. El taponamiento cardíaco se caracteriza por:

a. Hipotensión arterial, asociada a soplo diastólico
b. Hipertensión arterial, asociada a soplo diastólico
c. Disnea y dolor torácico
d. Hipotensión arterial, con ingurgitación yugular
e. Edema pulmonar y compromiso hemodinámico

Respuesta correcta: d. Hipotensión arterial, con ingurgitación yugular

Explicación: Se caracteriza por hipotensión arterial, ingurgitación yugular y ruidos cardíacos apagados. No tiene afectación pulmonar. El soplo diastólico sugiere disección aórtica e insuficiencia aórtica. El edema pulmonar más compromiso hemodinámico, sugiere insuficiencia cardíaca severa.

Fuente: Cirugía, cuestionario 8.2, P10

58. Un paciente de 68 años, diabético e hipertenso presenta un infarto con supradesnivel del segmento ST de la pared anterior, el que es manejado con trombolisis con estreptoquinasa, con respuesta clínica favorable. Dos meses después presenta un accidente vascular encefálico de arteria cerebral media y entre sus exámenes destaca un electrocardiograma con supradesnivel del segmento ST en las derivaciones precordiales, a pesar de no presentar angina en la actualidad. El diagnóstico más probable es:

a. Aneurisma ventricular
b. Rotura de la pared libre ventricular
c. Estenosis mitral postinfarto
d. Disección aórtica
e. Enfermedad ateromatosa carotidea extracraneal

Respuesta correcta: a. Aneurisma ventricular

Explicación: Es un aneurisma ventricular clásico, que puede presentarse con supradesnivel persistente del segmento ST (aunque es algo muy inespecífico, se suele enseñar y preguntar), a pesar de que ya no hay dolor (si tuviese dolor agudo y SDST, tendría un nuevo SCA). Además, se complica con embolias, arritmias o rotura de la pared ventricular. La rotura de pared ventricular en sí, suele ocurrir en la primera semana postinfarto y se caracteriza por un taponamiento agudo y, muchas veces, muerte súbita por dicha causa.

Fuente: Cirugía, cuestionario 8.2, P11

59. Un paciente de 70 años ha presentado síncopes en 2 ocasiones, por lo que se solicita una ecocardiografía que demuestra una válvula aórtica con una estenosis severa por degeneración

fibrocálcica. El estado basal del paciente es relativamente bueno, por lo que podría ser sometido a una cirugía, en caso de ser necesaria. ¿Cuál es la conducta más adecuada para este paciente?

a. Tratar de manera médica
b. Realizar recambio valvular con prótesis biológica, sin necesidad de anticoagulación a permanencia
c. Realizar recambio valvular con prótesis mecánica, sin necesidad de anticoagulación a permanencia
d. Realizar recambio valvular con prótesis biológica, con necesidad de anticoagulación a permanencia
e. Realizar recambio valvular con prótesis mecánica, con necesidad de anticoagulación a permanencia

Respuesta correcta: b. Realizar recambio valvular con prótesis biológica, sin necesidad de anticoagulación a permanencia

Explicación: Tanto por tener una valvulopatía sintomática, como por ser severa, está indicada la cirugía de reemplazo valvular. Por ser un adulto mayor, se prefiere la prótesis biológica, la que no requiere de anticoagulación. En cambio, si hubiese sido más joven, se indicaría una prótesis mecánica, la que sí requiere anticoagulación a permanencia, pero tiene una duración indefinida (la biológica solo dura 10 años).

Fuente: Cirugía, cuestionario 8.3, P18

60. Un paciente presenta dolor precordial, que aparece al caminar cerca de una cuadra y que le obliga a detenerse, desapareciendo a los 5 minutos de reposar. Como antecedente es diabético e hipertenso. Al examen físico no presenta alteraciones. Se solicita un electrocardiograma que resulta normal. La conducta más adecuada para proseguir el estudio es:

a. Solicitar ecocardiografía con dobutamina
b. Solicitar holter de arritmias
c. Solicitar test de esfuerzo
d. Solicitar coronariografía
e. Solicitar angioTAC de tórax

Respuesta correcta: c. Solicitar test de esfuerzo

Explicación: La angina estable se estudia con test de esfuerzo convencional (ECG de esfuerzo), que tiene mejor rendimiento que las otras pruebas de esfuerzo, como la ecografía o cintigrafía con drogas vasoactivas que simulan el esfuerzo físico. Por tanto, estas pruebas solo se usan cuando el test de esfuerzo convencional no puede ser realizado (ej. paciente amputado o que no tolera el ejercicio) o cuando no es interpretable (ej. BCRI). La coronariografía sí se pide, pero después de haber confirmado la isquemia con alguna de las pruebas mencionadas.

Fuente: Cirugía, cuestionario 8.4, P12

Neurocirugía (5)

61. Un paciente de 18 años presenta cefalea de inicio súbito, de intensidad muy alta, que se ha asociado a vómitos explosivos. El dolor inició hace siete horas y se ha agregado compromiso de conciencia. Se solicita un tac de cerebro sin contraste, que no muestra alteraciones. Además, se solicitan exámenes generales, que resultan normales. La conducta más adecuada es:

a. realizar resonancia magnética nuclear con contraste
b. realizar TAC de cerebro con contraste
c. realizar punción lumbar
d. realizar angiografía carotidea
e. iniciar medidas de neuro protección y anticoagular con heparina endovenosa

Respuesta correcta: c. realizar punción lumbar

Explicación: Tiene una clínica muy sugerente de hemorragia subaracnoidea (HSA): dolor de cabeza súbito, de gran intensidad y síntomas de HTEC. La forma en que se diagnostica es con el TAC de cerebro sin contraste. Sin embargo, cuando ha pasado mucho tiempo, como en este caso, pierde sensibilidad, por lo que si la sospecha es muy alta se debe hacer la PL (punción lumbar), que ve hemorragia antigua (xantocromía o glóbulos rojos crenados) o que no disminuye en los segundos siguientes a la punción (se llenan varios tubos con LCR y si el primero es hemático, pero los siguientes no, se asume que fue una sangrado por la punción; si, en cambio, se mantiene es por HSA).

Fuente: Cirugía, cuestionario 8.1, P18

62. Un paciente de 30 años presenta cefalea muy intensa, de inicio súbito, hace 20 minutos. Nunca había presentado cefalea de esas características. ¿Qué examen es el más adecuado para iniciar el estudio?

a. Punción lumbar y estudio de líquido cefalorraquídeo
b. Radiografía de cráneo
c. TAC de cerebro sin contraste
d. Resonancia magnética nuclear
e. No es necesario solicitar ningún examen

Respuesta correcta: c. TAC de cerebro sin contraste

Explicación: La sospecha es una hemorragia subaracnoidea, que se estudia con TAC de cerebro sin contraste. Si la sospecha es muy alta y el TAC resulta normal, se debe estudiar con una punción lumbar.

Fuente: Cirugía, cuestionario 8.2, P13

63. Un paciente de 60 años presenta, desde hace 2 semanas, cefalea progresiva, mayor en las mañanas, asociada a hemiparesia izquierda, que ha ido en aumento. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

a. Hematoma subdural crónico
b. Hemorragia subaracnoidea
c. Tumor cerebral
d. Absceso cerebral
e. Hematoma intraparenquimatoso

Respuesta correcta: c. Tumor cerebral

Explicación: La triada clásica del tumor cerebral es 1. Signos focales, 2. Convulsiones y 3. Hipiertensión endocraneana: HTEC (la que a su vez tiene 3 síntomas: cefalea mayor en la mañana, vómitos y compromiso de conciencia). Se estudia con RMN de cerebro (TAC con contraste puede servir, si no está

disponible la RMN). - El hematoma subdural tiene antecedente de TEC, aunque se puede dar de manera espontánea. - La hemorragia subaracnoidea es un cuadro agudo de cefalea muy intensa, súbita, con signos meníngeos e HTEC. - El absceso cerebral tiene la misma clínica del tumor, pero se le agrega la fiebre (la RMN será quien los diferencie). - El hematoma intraparenquimiatoso, o AVE hemorrágico, tiene un cuadro súbito de cefalea y signos focales.

Fuente: Cirugía, cuestionario 8.3, P9

64. ¿Cuál de las siguientes opciones es más sugerente de una hemorragia subaracnoidea?

a. Paciente de 30 años con cefalea progresiva, signos focales y convulsiones
b. Paciente de 20 años con cefalea muy intensa, de inicio súbito, con signos meníngeos
c. Paciente de 18 años con cefalea pulsátil, de localización frontal
d. Paciente de 60 años con cefalea, signos focales y fiebre
e. Paciente de 70 años con cefalea progresiva y aparición de compromiso de consciencia al día siguiente de un TEC

Respuesta correcta: b. Paciente de 20 años con cefalea muy intensa, de inicio súbito, con signos meníngeos

Explicación: El inicio ictal (súbito) y la intensidad son características. Los signos meníngeos suelen aparecer más tarde. Las demás alternativas son: A (tumor cerebral), C (jaqueca), D (absceso cerebral), E (hematoma subdural).

Fuente: Cirugía, cuestionario 8.4, P5

65. Un paciente de 50 años presenta dolor de cabeza, mayor en las mañanas, que lo despierta en la noche y que ha ido aumentando progresivamente. Además, refiere hemiparesia izquierda progresiva. ¿Qué examen es más adecuado para el estudio de este paciente?

a. Angiografía carotidea
b. TAC de cerebro sin contraste
c. RMN de cerebro
d. Radiografía de cráneo
e. Ecodoppler de arterias carótidas

Respuesta correcta: c. RMN de cerebro

Explicación: La asociación de hipertensión endocraneana (cefalea matinal, náuseas y edema de papila), signos focales y convulsiones sugieren un tumor cerebral. Acá solo se ve la cefalea con signos de alarma y los signos focales (hemiparesia), por lo que se debe descartar el tumor, con RMN de cerebro (habría sido útil un TAC con contraste, pero la RMN es superior).

Fuente: Cirugía, cuestionario 8.4, P18

Patología mamaria y oncología quirúrgica (5)

66. ¿Cuál es la función que cumple la radioterapia en el tratamiento del cáncer de mama?

a. Ninguna
b. Disminuye la recidiva local
c. Disminuye el riesgo de metástasis linfáticas
d. Disminuye el riesgo de metástasis a distancia
e. Potencia el efecto de la hormonoterapia

Respuesta correcta: b. Disminuye la recidiva local

Explicación: La cirugía sigue siendo el tratamiento más importante, con iguales resultados oncológicos tanto en la mastectomía total como en la mastectomía parcial, por lo que se prefiere esta última, debido a su mejor resultado estético. La radioterapia se da actualmente en prácticamente todos los casos para reducir la recidiva local. La hormonoterapia se indica en pacientes con receptores positivos para estrógeno y/o progesterona. Aunque el tamoxifeno ha sido el clásico fármaco y aún se puede utilizar, actualmente se prefieren los inhibidores de la aromatasa, como el anastrozol, letrozol y exemestano. En los tumores que sobre expresan el gen HER-2, se recomienda agregar el trastuzumab (herceptin), salvo que sea muy pequeño (<1 cm) y esté localizado. La quimioterapia se suele agregar en los tumores grandes, avanzados, con histología desfavorable o "triple negativo" (negatividad de receptores de estrógeno y progesterona, que no sobre expresa el gen HER-2).

Fuente: Cirugía, cuestionario 8.1, P4

67. Una paciente de 60 años se realiza una mamografía de control, que es informada como Birrads 4, por presencia de un nódulo mamario denso y con espículas, de cerca de 2 cm de diámetro. Se realiza biopsia estereotáxica, que demuestra presencia de adenocarcinoma ductal infiltrante, con grado moderado de diferenciación e invasión vascular en la histología. La biopsia de ganglio centinela, así como el estudio de diseminación resultan negativos. La conducta más adecuada es:

a. Realizar mastectomía total más quimioterapia postoperatoria
b. Realizar mastectomía parcial
c. Realizar mastectomía parcial más radioterapia postoperatoria
d. Realizar hormonoterapia más quimioterapia
e. Realizar hormonoterapia más radioterapia

Respuesta correcta: c. Realizar mastectomía parcial más radioterapia postoperatoria

Explicación: Es una pregunta muy específica. Una mamografía Birrads 4 se debe biopsiar histológicamente (aguja gruesa, trucut, mamótomo o estereotáxica, por ejemplo). El cáncer de mama se trata basalmente con mastectomía parcial (la mastectomía total solo se indica en cáncer multifocal, bilateral, asociada a genes BRCA1 o BRCA2 o en la desproporción tumor/mama). - Además, se suele dar radioterapia postoperatoria (salvo casos muy excepcionales). - La hormonoterapia se dan en los cánceres que hay positividad de los receptores de estrógeno y/o de progesterona. Actualmente se indica independiente del grado de diseminación. De elección se usan los inhibidores de la aromatasa (anastrozol, letrozol y exemestano), aunque aún se puede usar el tamoxifeno. - La quimioterapia se usa en los grandes, con histología desfavorable (ej. indiferenciado o triple negativo: nagatividad de receptores de estrógeno, receptores de progesterona y sobreexpresión HER-2) o diseminados. De las opciones las más aceptable pareciera ser la mastectomía parcial más radioterapia, aunque el manejo real puede llegar a ser mucho más complejo.

Fuente: Cirugía, cuestionario 8.2, P1

68. Identifique la asociación INCORRECTA entre el cáncer y el factor pronóstico más importante:

a. Cáncer de mama – compromiso linfático
b. Cáncer de estómago – invasión transmural
c. Cáncer de esófago – tipo histológico
d. Cáncer de colon – invasión transmural
e. Cáncer de cabeza y cuello – compromiso linfático

Respuesta correcta: c. Cáncer de esófago – tipo histológico

Explicación: El factor pronóstico más importante en el cáncer esofágico es la invasión transmural, al igual que en todo el tubo digestivo. Las demás son correctas. Algunos otros factores pronósticos, a recordar son: Melanoma – Breslow Sarcoma – Grado de diferenciación histológico Endometrio – Invasión transmural Ovario – Compromiso peritoneal Cuello uterino – Invasión de parametrios

Fuente: Cirugía, cuestionario 8.2, P9

69. Una paciente de 40 años se realiza su primera mamografía, la que es informada como Birrads 0. La conducta más adecuada es:

a. Controlar con nueva mamografía en un año
b. Solicitar nueva mamografía en 6 meses
c. Solicitar una nueva mamografía de inmediato
d. Solicitar ecografía mamaria
e. Derivar para biopsia

Respuesta correcta: d. Solicitar ecografía mamaria

Explicación: Birrads 0 significa que la mamografía no se puede interpretar, seguramente por tener mamas muy densas. Se debe estudiar con otro examen: la ecografía. - Birrads 0 (no interpetable) = ecografía. - Birrads 1 (normal) = mamografía en 1 año. - Birrads 2 (lesión benigna) = mamografía en 1 año. - Birrads 3 (lesión probablemente benigna) = mamografía en 6 meses (y se puede complementar con ecografía; es más, algunos aceptan tanto la ecografía como la mamografía como examen de seguimiento, pero la mamografía cuneta con más evidencia). - Birrads 4 (lesión sospechosa) = biopsia histológica (estereotáxica si no hay un tumor palpable; con aguja gruesa o mamótomo si es palpable). - Birrads 5 (cáncer) = biopsia quirúrgica, aunque es correcto realizar una biopsia histológica por punción y, si sale negativa, volver a biopsiar.

Fuente: Cirugía, cuestionario 8.3, P17

70. Una paciente de 50 años se palpa un nódulo mamario duro, de cerca de 3 cm de diámetro, asociado a cambio en la piel de la mama, la que se aprecia con pequeñas depresiones en “piel de naranja”. Se realiza una mamografía, que visualiza un nódulo denso, espiculado, con varias microcalcificaciones agrupadas. El diagnóstico más probable es:

a. Mastopatía fibroquística
b. Fibroadenoma
c. Carcinoma ductal invasor
d. Papiloma intraductal
e. Quiste simple

Respuesta correcta: c. Carcinoma ductal invasor

Explicación: Tanto clínicamente, como en la mamogarfía (Birrads 4-5 en este caso) es muy sugerente de un cáncer de mama. El carcinoma ductal invasor es el más frecuente.

Fuente: Cirugía, cuestionario 8.4, P7

Patología tiroidea y cervical (5)

71. Un paciente de 24 años se palpa un aumento de volumen en el cuello. Al examen físico se aprecia dicho aumento de volumen en relación a la línea media del cuello en la zona supra esternal, que se moviliza con la deglución. Se solicita una TSH que resulta normal y una ecografía de cuello que visualiza un

tumor quístico de 20 mm de diámetro, sin otras alteraciones, en relación a la glándula tiroides. La conducta más adecuada es:

a. Solicitar una cintigrafía de tiroides
b. Solicitar niveles plasmáticos de T3 y T4
c. Iniciar levotiroxina oral
d. Realizar biopsia por punción con aguja fina
e. Observar evolución

Respuesta correcta: e. Observar evolución

Explicación: El nódulo tiroideo y los nódulos cervicales en general, se estudian inicialmente con ecografía de cuello (antes se solicita TSH eso sí). Luego, se procede a la biopsia por punción con aguja fina, si es mayor a 10 mm (Minsal, guía antigua) o, de acuerdo al aspecto ecográfico Tirrads: - TR1: no hay nódulo. - TR2: quiste simple = observar. - T3 y T4: PAAF si > 10-15 mm. - T5: PAAF siempre (difícil si <5 mm). En este caso, por ser quístico, sin otras alteraciones ecográficas, dejaremos la recomendación actualizada que es observar evolución. La excepción es el nódulo con TSH baja (hipertiroideo), en que se pide la cintigrafía. Si es hipercaptante (caliente), se trata con I131 o cirugía. Si es hipocaptante o normocaptante (frío), se punciona, de acuerdo a lo ya explicado, para saber qué es.

Fuente: Cirugía, cuestionario 8.1, P2

72. Un paciente es diagnosticado de cáncer papilar de tiroides, mediante una biopsia aspirativa. Se realizar tiroidectomía total, sin complicaciones. La conducta más adecuada es:

a. iniciar levotiroxina
b. solicitar cintigrafía con yodo radiactivo
c. solicitar niveles plasmáticos de TSH y T4
d. solicitar niveles plasmáticos de tiroglobulina y calcitonina
e. realizar radioterapia cervical externa

Respuesta correcta: b. solicitar cintigrafía con yodo radiactivo

Explicación: Luego de la PAAF (punción aspiración con aguja fina), se hace el diagnóstico de cáncer de tiroides. Si es un cáncer papilar o folicular, se debe tratar con cirugía, en específico, la tiroidectomía total (solo en casos muy seleccionados se hace una hemitiroidectomía: tumor <1 cm sin adenopatías ni metástasis). - Luego de la cirugía se debe evaluar si queda tumor remanente con niveles de tiroglobulina, TSH y muchos piden, además, la cintigrafía tiroidea. - Luego se da yodo radiactivo (I131), pero, la dosis se ajusta según el riesgo, de acuerdo a la histología, niveles de tiroglobulina y resultados de la cintigrafía con I131 (yodo radiactivo) postquirúrgica. - Finalmente se sigue con tiroglobulina (Tg). También se sigue con examen físico, ecografía de cuello, TSH y T4 libre, pero la Tg es lo más importante. En el cáncer medular, el tratamiento es principalmente quirúrgico (antes se debe descartar que no haya un feocromocitoma, con metanefrinas urinarias, hacer estudio genético de neoplasias endocrinas múltiples, solicitar niveles preoperatorios de calcitonina y antígeno carcinoembrionario). Luego, si está avanzado, se hace QT y/o RT, al igual que los demás cánceres de cabeza y cuello. - No sirve el I131. - Se sigue con calcitonina plasmática y antígeno carcinoembrionario (CEA).

Fuente: Cirugía, cuestionario 8.1, P14

73. Respecto al carcinoma papilar de tiroides es verdadero que:

a. Presenta elevación de la calcitonina
b. Suele diseminarse por vía hematógena

c. Se diagnostica mediante biopsia excisional

d. Capta yodo radiactivo

e. Es menos frecuente que el carcinoma folicular

Respuesta correcta: d. Capta yodo radiactivo

Explicación: El carcinoma medular eleva la calcitonina. El carcinoma folicular se disemina por vía hematógena. En cambio, el papilar y el medular, lo hacen por vía linfática. El cáncer de tiroides se diagnostica por punción con aguja fina. Los carcinomas folicular y papilar son los que captan yodo radiactivo. El cáncer papilar es el 85% del total de cánceres de tiroides. Le sigue el folicular, con un 10% y luego el medular, con un 5%. El anaplásico es menos del 1% de los casos.

Fuente: Cirugía, cuestionario 8.3, P19

74. Una paciente se realiza una tiroidectomía total por cáncer papilar de tiroides. ¿Debe recibir antibióticos?

a. No, los antibióticos no son necesarios

b. Sí, requiere profilaxis antibiótica durante la cirugía

c. Sí, requiere profilaxis antibióticas durante el día de la cirugía y los 3 días siguientes

d. Sí, requiere profilaxis antibióticas durante el día de la cirugía y los 7 días siguientes

e. Sí, requiere profilaxis antibióticas durante los 3 días previos a la cirugía y los 7 días siguientes

Respuesta correcta: a. No, los antibióticos no son necesarios

Explicación: Es una herida limpia (no abre mucosa), por lo que, salvo excepciones (cirugías con prótesis o de órganos muy riesgosos: ej. neurocirugía) no requiere antibióticos profilácticos.

Fuente: Cirugía, cuestionario 8.4, P4

75. Respecto al cáncer de tiroides es verdadero que:

a. El cáncer medular se caracteriza por elevación de la tiroglobulina

b. El carcinoma folicular se disemina preferentemente por vía linfática

c. El carcinoma papilar se trata con tiroidectomía total y posteriormente, yodo radiactivo

d. El carcinoma medular capta yodo radiactivo

e. El diagnóstico de cáncer de tiroides se suele hacer mediante tumorectomía y biopsia excisional

Respuesta correcta: c. El carcinoma papilar se trata con tiroidectomía total y posteriormente, yodo radiactivo

Explicación: - Tanto el cáncer papilar, como el folicular se tratan con tiroidectomía total y luego se da levotiroxina (para TSH <0,1 o 0,4 según varias variables) y yodo radiactivo, cuya dosis se ajusta con la cintigrafía o otros estudios de diseminación. - El cáncer medular eleva la calcitonina (la tiroglobulina sirve para seguir al papilar y folicular). - El folicular se disemina vía hematógena (papilar y medular por vía linfática). - El medular no capta yodo radiactivo. - El diagnóstico de todos los cánceres de tiroides se hace con PAAF.

Fuente: Cirugía, cuestionario 8.4, P19

Complicaciones postoperatorias y profilaxis antibiótica (6)

76. ¿A qué tipo de herida corresponde una mastectomía parcial, por un cáncer de mama?

a. herida limpia

b. herida limpia-contaminada

c. herida contaminada
d. herida sucia
e. herida infectada

Respuesta correcta: a. herida limpia

Explicación: No abre mucosas, por lo que es limpia. A diferencia de las heridas limpias-contaminadas (abren mucosas) y contaminadas, por regla general, en las heridas limpias (no abren mucosas y buena técnica) no se requiere profilaxis antibiótica, pero, existe algunas en las que sí se recomienda (con cefazolina, ya que se infectan con Staphilococcus aures y coagulasa negativo). A continuación las excepciones: Cardíacas en las que se implantan prótesis o dispositivos (marcapasos, stent coronario). También by-pass coronario. Vasculares en las que se implantan prótesis, abren aorta abdominal o se accede por vía inguinal. Traumatológicas en las que se implanta prótesis articulares, en toda fractura de cadera, amputación de extremidad por isquemia, cirugía espinal. Mama: Cáncer de mama (mastectomía, disección ganglionar). Tórax: toracotomía (aunque no llegue al pulmón) Neuroquirúrgica: craneotomía (con o sin apertura de meninges), implante de dispositivos (ej. válvula de derivación de LCR).

Fuente: Cirugía, cuestionario 8.1, P9

77. Un paciente de 65 años consulta por dolor abdominal muy intenso, asociado a vómitos alimentarios. En sus exámenes se solicita hemograma, que muestra claro aumento de los glóbulos blancos. Además, se solicita lipasa plasmática, que resulta 625 UI/L. El TAC de control muestra necrosis del 50% del páncreas, con reacción inflamatoria periférica. El paciente evoluciona desfavorablemente, con marcado deterioro del estado general, por lo que se decide realizar una punción pancreática, la que muestra un cultivo positivo para Klebsiella pneumoniae. La conducta más adecuada es:

a. indicar antibióticos orales y régimen cero
b. Indicar antibióticos endovenosos y régimen cero
c. indicar antibióticos endovenosos y resolver mediante debridación quirúrgica
d. resolver quirúrgicamente, sin necesidad de antibióticos
e. realizar punción aspirativa de la necrosis e iniciar tratamiento antibiótico

Respuesta correcta: c. indicar antibióticos endovenosos y resolver mediante debridación quirúrgica

Explicación: El diagnóstico de pancreatitis se realiza con lipasa por 3 veces el valor normal (sobre 180 UI/L suele ser diagnóstica; la amilasa es menos específica). La TAC es el mejor examen para ver el páncreas, pero no se usa con fines diagnósticos (salvo que existe duda), sino más bien pronósticos, solicitándose 48 a 72 horas después del inicio de los síntomas. Sin embargo, lo más importante para determinar la gravedad es el compromiso de otros órganos, con muchos exámenes de laboratorio, para, por ejemplo, calcular el score de APACHE. El tratamiento básico es 1. Régimen cero, 2. Hidratación endovenosa y 3. Analgésicos (AINEs). En los casos leves no suele ser necesario alimentar por otras vías y la realimentación oral se puede reiniciar a los pocos días. En los casos moderados a severos, se suele recomendar la nutrición enteral (por sonda), ya que tiene menos complicaciones y costos que la parenteral. Los antibióticos están indicados en la necrosis infectada, la cual debe ser sospechada en toda pancreatitis grave o que evoluciona mal. La punción con aguja fina y cultivo sirven, pero la clínica parece ser el mejor indicador, por lo que muchos no recomiendan la punción. La cirugía está reservada a los casos con necrosis infectada muy grave (ej. hemodinamia inestable) o que, usando antibióticos, empeora o no revierte en 4 semanas. La causa debe ser tratada (ej. realizar colecistectomía en litiasis, suspender el alcohol y tratar hipertrigliceridemia). En los casos en que la causa sospechada es la litiasis, además, se recomienda una CPRE urgente, para retirar el cálculo del colédoco.

Fuente: Cirugía, cuestionario 8.1, P10

78. Un paciente de 56 años es operado de un cáncer de colon, con una hemicolectomía izquierda, más anastomosis primaria. Al cuarto día postoperatorio inicia fiebre y disnea, asociada a dolor torácico de tipo puntada. Al examen está algo taquicárdico y disneico, saturando 91% a FiO2 ambiental. Su murmullo pulmonar está presente, simétrico, con algunos crépitos en la base derecha. El diagnóstico más probable es:

a. Atelectasia
b. Neumotórax
c. Neumonía
d. Aspiración de cuerpo extraño
e. Tromboembolismo pulmonar

Respuesta correcta: e. Tromboembolismo pulmonar

Explicación: Es una pregunta difícil, ya que los síntomas calzan con más de un diagnóstico. Sin embargo, tiene un TEP clásico, debido tanto a la cirugía, como al cáncer, que aumentan el riesgo. La disnea, desaturación y dolor tipo puntada de costado son característicos y también es frecuente que tenga fiebre. El inicio de los síntomas suele ser súbito, lo que lo diferencia de las demás causas. El examen pulmonar puede estar normal o mostrar cualquier tipo de alteraciones inespecíficas (como los crépitos, en este caso). - La atelectasia se habría preguntado como fiebre al día siguiente de la cirugía (además podía tener tos seca y crepitaciones). Sin embargo, actualmente se sabe que las atelectasias NO son causa de fiebre en el posoperatorio, sino que simplemente coincidía que había fiebre y atelectasias porque ambas eran frecuentes. Hoy se sabe que la fisiopatología de la fiebre posquirúrgica transitoria de las primeras 48 horas es la liberación de citoquinas y de endotoxinas de las bacterias de la flora bacteriana, entre otras. - El neumotórax tiene hipersonoridad, disminución del murmullo pulmonar y dolor tipo puntada de costado, pero no tiene fiebre ni se relaciona con la cirugía. - La neumonía se habría preguntado con tos con expectoración mucopurulenta, fiebre, dolor tipo de puntada de costado, crépitos (en otras palabras, este caso sí puede ser una neumonía), pero los antecedentes obligan, no solo a marcar TEP, sino a descartar primeramente el TEP con un angioTAC. Esta es la clásica pregunta difícil de TEP, que se pregunta similar a una neumonía postquirúrgica.

Fuente: Cirugía, cuestionario 8.2, P2

79. La causa más frecuente de fiebre postoperatoria tardía, es decir aquella que inicia pasado las 48 horas, es:

a. Atelectasias
b. Neumonía
c. Infección urinaria
d. Tromboflebitis y trombosis venosa profunda
e. Infección de la herida operatoria

Respuesta correcta: e. Infección de la herida operatoria

Explicación: Resumen actualizado de causas de fiebre postquirúrgica. - La causa más frecuente de fiebre postoperatoria, en especial en las primeras 48 horas, suele ser la liberación de sustancias inflamatorias (ej. citoquinas y endotoxinas bacterianas) debido a la agresión quirúrgica misma o al uso de fármacos. Antiguamente se atribuía a las atelectasias, pero hoy se sabe que no hay relación de causalidad, sino que las atelectasias eran bastante frecuentes y simplemente coincidía su presencia con la de la fiebre. - Después de las primeras 48 horas, la causa más frecuente es la infección de la herida quirúrgica, pero suele producirse entre el día 4 y 7. - Entre el día 3 y 4, son más frecuentes las tromboflebitis, TVP y TEP. La nemotecnia clásica para recordar la causa (se deben buscar todas en el paciente real) eran las 5W. - Wind:

neumonía, TEP (ya no atelectasias). - Wound: infección de herida operatoria. - Water: infección urinaria. - Walk: TVP y tromboflebitis. - Wonderful drugs: reacciones a fármacos (hipertermia maligna es inmediatamente después de la cirugía).

Fuente: Cirugía, cuestionario 8.2, P7

80. Un paciente de 56 años se realiza una endoscopía digestiva alta de control, la que resulta normal, sin embargo, algunos minutos después presenta dolor retroesternal, que va en aumento y que se exacerba con la inspiración y al tragar. El diagnóstico de sospecha es:

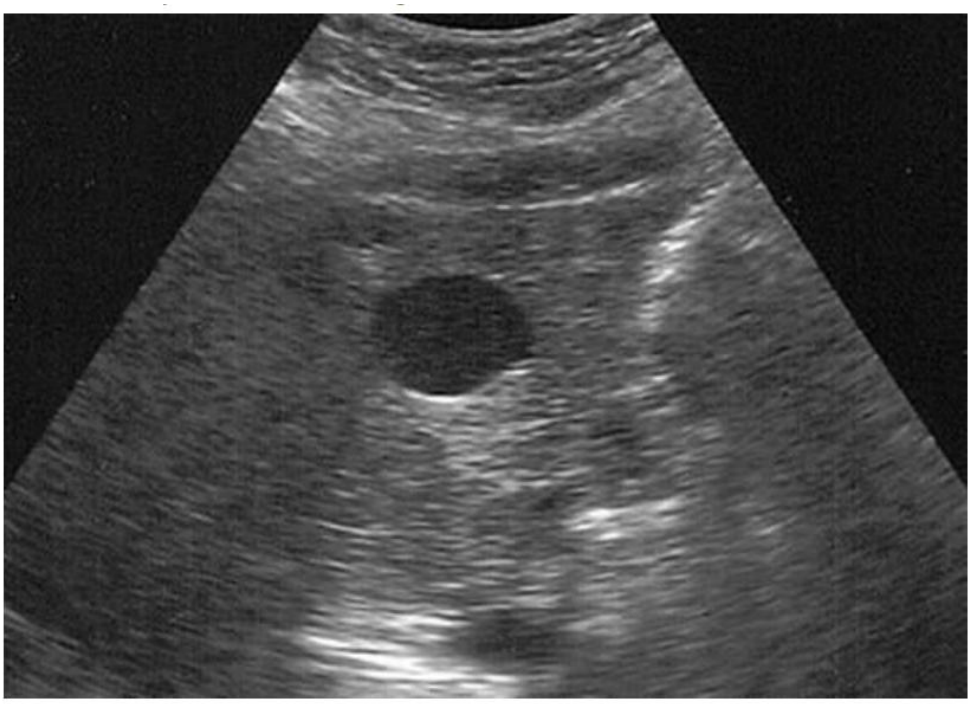
a. Neumotórax
b. Espasmo esofágico difuso
c. Divertículo esofágico
d. Síndrome de Mallory Weiss
e. Perforación esofágica

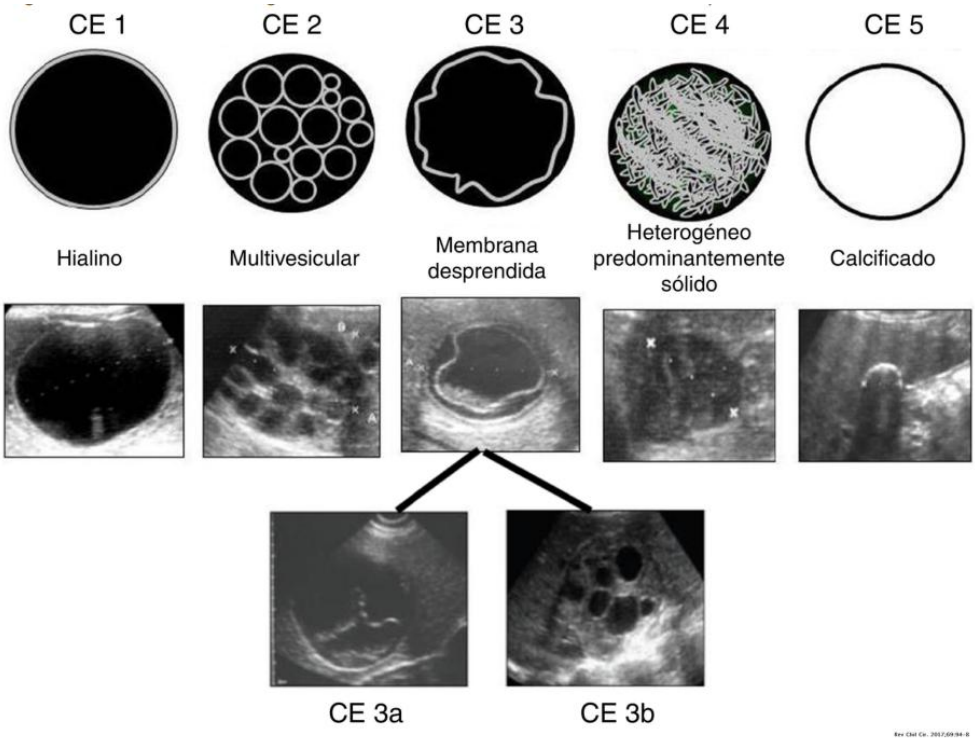
Respuesta correcta: e. Perforación esofágica

Explicación: La causa más frecuente de perforación esofágica es secundaria a las endoscopías digestivas. Su clínica es disfagia y luego evoluciona a una mediastinitis aguda, con neumomediastino. Se estudia con TAC de tórax y abdomen (que ve el neumomediastino) y el tratamiento es la reparación quirúrgica. Solo casos excepcionales se pueden tratar con una conducta expectante, con régimen cero y antibióticos parenterales (perforación pequeña, asintomática, detectada durante la misma endoscopía que lo produce y que no se deteriora). La mediastinitis aguda es muy grave y requiere de antibióticos de amplio espectro por vía endovenosa, más drenaje quirúrgico. - El espasmo esofágico tiene dolor retroesternal intenso, inespecífico, con antecedente de reflujo y que cede con los nitritos. - El neumotórax no tiene disfagia, pero sí dolor torácico unilateral, que aumenta con la inspiración. - El divertículo esofágico tiene disfagia crónica, asociada a regurgitación no ácida, halitosis y neumonías aspirativas. - El síndrome de Mallory Weiss tiene hematemesis antecedida de vómitos alimentarios.

Fuente: Cirugía, cuestionario 8.2, P19

81. Un paciente se realiza una ecografía abdominal, que visualiza una lesión hepática, anecogénica de 3 cm de diámetro, con refuerzo posterior, sin bordes visibles. La conducta más adecuada es:





a. Solicitar colonoscopía
b. Observar evolución
c. Solicitar TAC de abdomen y pelvis
d. Iniciar albendazol y resolver quirúrgicamente en una segunda instancia
e. Solicitar alfafetoproteína plasmática

Respuesta correcta: b. Observar evolución

Explicación: Es un quiste hepático simple (lesión anecogénica, sin bordes y con refuerzo posterior). Se debe observar. A continuación, una imagen de quiste hepático simple: Fuente: https://www.ecodigest.net/atlas/aeed/1/lesiones-focales/ - El quiste hidatídico tiene bordes visibles (ya sea pegados o despegados), tabiques o vesículas hijas. Se trata con albendazol oral por varios meses y, en muchos casos, punción e inyección de alcohol (solo los totalmente inactivos se pueden observar: tipos 4 y 5). A continuación, imágenes de quistes hidatídicos y sus variaciones: Fuente: Revista Chilena de Cirugía (https://www.elsevier.es/es-revista-revista-chilena-cirugia-266-articulo- diagnostico-tratamiento-seguimiento-hidatidosis-S0379389316301399).

Fuente: Cirugía, cuestionario 8.3, P10

Traumatología y ortopedia (94)

Fracturas y luxaciones del miembro superior (20)

1. Una mujer de 18 años presenta una caída de altura, mientras corría, cayendo apoyada sobre sus dos manos, en extensión. Inmediatamente presenta dolor, en relación al antebrazo izquierdo, que luego aumenta. El dolor se vuelve mucho más intenso al realizar movimientos de pronosupinación. El diagnóstico de sospecha es:

a. Atrapamiento cubital
b. Fractura de antebrazo
c. Luxación de codo
d. Fractura de olécranon
e. Fractura de cúpula radial

Respuesta correcta: e. Fractura de cúpula radial

Explicación: Es una fractura de la cúpula radial clásica: caída a nivel, con apoyo de la extremidad superior en extensión, que presenta dolor en especial a la pronosupinación. Además, es frecuente que afecte a mujeres jóvenes o a hombres jóvenes delgados. El atrapamiento cubital, es un cuadro crónico, con parestesias y debilidad a la flexión de los 4° y 5° dedos. La fractura de antebrazo suele darse por golpe directo y presenta dolor a todos los movimientos del antebrazo. La fractura de olécranon suele ser por caída con golpe en el codo y presenta dolor en la punta del codo (que corresponde al olécranon).

Fuente: Traumatología y ortopedia, cuestionario 7.1, P2

2. Un paciente sufre un raquetazo en la mano izquierda. Presenta imposibilidad de extender por completo el dedo medio, tal como se muestra en la fotografía (fuente: https://www.assh.org/handcare/blog/) y la radiografía descarta lesiones óseas. La conducta más adecuada es:



a. Solicitar TAC de dedo
b. Resolver quirúrgicamente
c. Indicar inmovilización con férula, en extensión
d. Indicar inmovilización con férula, en flexión
e. Indicar analgésicos y kinesioterapia

Respuesta correcta: c. Indicar inmovilización con férula, en extensión

Explicación: Tiene un “mallet finger” o “dedo en martillo”. Se produce por rotura de la fascia extensora y se trata ortopédicamente con inmovilización estricta con el dedo en extensión. Si no se trata

oportunamente, evoluciona con imposibilidad crónica de extender la falange distal. Casos excepcionales requieren cirugía.

Fuente: Traumatología y ortopedia, cuestionario 7.1, P5

3. Un paciente sufre una caída a nivel, mientras jugaba basquetbol, resultando con un golpe en el hombro contra el suelo. Presenta dolor y dificultad en los movimientos, por lo que se solicita una radiografía, que muestra lo siguiente (fuente: http://osteomuscular.com/HOMBRO/trauma...): El diagnóstico más probable es:



a. Fractura de hombro
b. Fractura de clavícula
c. Luxación anterior de hombro
d. Disyunción acromioclavicular
e. Contusión de hombro

Respuesta correcta: d. Disyunción acromioclavicular

Explicación: Tiene una disyunción acromioclavicular izquierda, ya que se aprecia que hay un aumento en el espacio acriomioclavicular, así como en el espacio entre la clavícula y la escápula en general. La imagen mostrada es la clásica radiografía AP comparativa de hombros en una sola placa.

Fuente: Traumatología y ortopedia, cuestionario 7.1, P14 · Traumatología y ortopedia, cuestionario 7.5, P14

4. Un paciente sufre un golpe en el brazo izquierdo, evolucionando con gran dolor y pérdida de los ejes. Se solicita una radiografía de brazo, que se muestra a continuación (fuente: https://es.slideshare.net/julio938/radiologia-basica- traumatologia): ¿Qué estructura se ha lesionado con mayor probabilidad?



a. Nervio axilar
b. Arteria braquial
c. Nervio radial
d. Arteria circunfleja
e. Nervio cubital

Respuesta correcta: c. Nervio radial

Explicación: Tiene una fractura de la diáfisis humeral. Si bien también se puede dañar la arteria braquial, la estructura que más se daña es el nervio radia, ya que está en estrecho contacto con el húmero.

Fuente: Traumatología y ortopedia, cuestionario 7.1, P15

5. Una paciente presenta una caída de un metro de altura, cayendo contra el suelo, apoyando el codo. Presenta aumento de volumen y signos de derrame articular, por lo que se decide realizar punción articular, que da salida a sangre, con gotas de grasa, que flotan en su superficie. El diagnóstico más probable es:

a. Luxación de codo
b. Fractura de codo
c. Rotura del tendón tricipital
d. Rotura del tendón bicipital
e. Luxación de la cúpula radial

Respuesta correcta: b. Fractura de codo

Explicación: Las gotas de grasa indican que hay una fractura, ya que es grasa proveniente de la médula ósea.

Fuente: Traumatología y ortopedia, cuestionario 7.1, P18

6. Un paciente de 25 años presenta una caída a nivel, apoyando las extremidades superiores contra el suelo, en extensión. Evoluciona posteriormente con dolor, que es especialmente intenso al presionar la tabaquera anatómica. Por esto se solicita radiografía de mano, que no muestra alteraciones. La conducta más adecuada es:

a. Indicar AINEs y enviar a domicilio, sin necesidad de exámenes ni medidas adicionales
b. Indicar AINEs y kinesioterapia motora de la mano
c. Solicitar TAC de mano y decidir conducta según resultado
d. Solicitar cintigrafía ósea
e. Resolver quirúrgicamente de inmediato

Respuesta correcta: c. Solicitar TAC de mano y decidir conducta según resultado

Explicación: La sospecha diagnóstica es una fractura de escafoides, la que puede no verse en la radiografía. Sin embargo, tiene riesgo de necrosis avascular, por lo que es fundamental diagnosticarla. De primera línea, se pide una radiografía de carpo (o de mano) y en caso de estar normal, hay dos opciones: 1. Solicitar un TAC o RMN (ya que tienen mejor rendimiento) y decidir según resultado o 2. Inmovilizar, tal como si fuera una fractura no desplazada y controlar con nueva radiografía en 1-2 semanas (si hay fractura, se sigue inmovilizando; si no, se retira la inmovilización.

Fuente: Traumatología y ortopedia, cuestionario 7.2, P1

7. Un paciente sufre una caída a nivel, con golpe del hombro contra el suelo. Al examen presenta el signo de la charretera, confirmándose una luxación anterior de hombro. Como antecedente, refiere otra luxación ipsilateral, hace 6 meses, por un traumatismo similar, la que fue manejada con reducción cerrada y manejo ortopédico. La conducta más adecuada es:

a. Reducir y realizar vendaje en 8
b. Reducir e inmovilizar con cabestrillo bloqueado
c. Indicar kinesioterapia motora
d. Reducir e inmovilizar con yeso toracobraquial

e. Resolver quirúrgicamente

Respuesta correcta: e. Resolver quirúrgicamente

Explicación: La luxación recurrente de hombro se debe resolver mediante cirugía, ya que el riesgo de que vuelva a luxarse es demasiado alto. Si solo es una luxación, se realiza reducción cerrada más inmovilización. En cambio, la primera luxación, salvo escasas excepciones, se maneja con tratamiento ortopédico (reducción cerrada e inmovilización). Ninguna de las técnicas de reducción ha demostrado ser mejor que las otras. Tampoco los distintos tipos de inmovilización han demostrado superioridad.

Fuente: Traumatología y ortopedia, cuestionario 7.2, P10

8. Una mujer de 23 años sufre una caída a nivel, apoyando la mano derecha contra el suelo. Evoluciona con dolor en el antebrazo, que es especialmente doloroso al realizar movimientos de pronosupinación. La sospecha diagnóstica es:

a. Luxación de codo
b. Pronación dolorosa
c. Fractura de olécranon
d. Fractura de apófisis coronoide
e. Fractura de cúpula radial

Respuesta correcta: e. Fractura de cúpula radial

Explicación: Es una fractura clásica de la cúpula radial, en especial, por el dolor al pronosupinar. La luxación de codo tendría imposibilidad de hacer movimientos con el codo y deformación. La pronación dolorosa sí duele en la pronosupinación (se produce por luxación de la cúpula radial), pero afecta a niños y por un mecanismo de tracción de la extremidad, no por caída. La fractura del olécranon tiene dolor a la palpación del olécranon (vértice del codo) y equimosis en el codo.

Fuente: Traumatología y ortopedia, cuestionario 7.2, P16

9. Un paciente sufre una fractura de diáfisis humeral, evolucionando con imposibilidad de extender la muñeca. El diagnóstico más probable es:

a. Lesión del nervio radial
b. Lesión del nervio cubital
c. Lesión del nervio mediano
d. Lesión del nervio musculocutáneo
e. Lesión del nervio axilar

Respuesta correcta: a. Lesión del nervio radial

Explicación: Tanto por la fractura de diáfisis humera, como por la clínica, es una lesión del nervio radial clásica. La lesión del nervio cubital produce imposibilidad de flectar el meñique y anular y afectación de la sensibilidad de esos dedos. La lesión del mediano es igual, pero afectando el pulgar, índice y mediano. La lesión del nervio musculocutáneo afecta la flexión del brazo (ya que inerva al bíceps) y la sensibilidad de la cara lateral del antebrazo. La lesión del nervio axilar o circunflejo es secundaria a la luxación anterior de hombro y tiene debilidad a la abducción del hombro y anestesia en la zona deltoidea.

Fuente: Traumatología y ortopedia, cuestionario 7.2, P17

10. Un paciente sufre una contusión en el hombro derecho, producto de una caída a nivel, persistiendo con dolor a la movilidad. Al examen presenta dolor a la palpación de la unión acromio-clavicular. ¿Qué radiografía es la más importante para confirmar la sospecha diagnóstica?

a. AP de hombro derecho
b. Lateral de hombro derecho
c. AP de hombros bilateral comparativa con y sin carga
d. AP de clavícula en abducción
e. AP de escápula en abducción

Respuesta correcta: c. AP de hombros bilateral comparativa con y sin carga

Explicación: La sospecha diagnóstica es una luxación acromio clavicular o disyunción acromioclavicular, que se estudia con la radiografía AP bilateral comparativa de hombros ya sea en una sola radiografía que vea ambos hombros o en 2 radiografías distintas, que se ponen una junto a la otra para comparar. Está obsoleto el realizarlo con y sin carga, ya que estudios nuevos han demostrado que no varía la sensibilidad. El manejo es ortopédico en las leves y quirúrgico en las severas (se clasifican del I al VI y se operan desde el IV en adelante).

Fuente: Traumatología y ortopedia, cuestionario 7.3, P3

11. ¿Qué estructura se daña más frecuentemente en la luxación anterior de hombro?

a. Nervio radial
b. Nervio circunflejo
c. Arteria circunfleja anterior
d. Arteria circunfleja posterior
e. Nervio mediano

Respuesta correcta: b. Nervio circunflejo

Explicación: Se daña el nervio circunflejo o axilar. También se pueden dañar las arterias circunflejas, pero lo más frecuente es el nervio axilar.

Fuente: Traumatología y ortopedia, cuestionario 7.3, P20

12. Un paciente sufre una caída en bicicleta, golpeándose el hombro izquierdo contra el suelo. Evoluciona con dolor importante, en especial a los movimientos del hombro. Al examen físico se aprecia dolor en la zona acromio-clavicular y signo de la “tecla de piano”. El diagnóstico es:

a. Luxación anterior de hombro
b. Luxación posterior de hombro
c. Disyunción acromioclavicular
d. Fractura de clavícula
e. Fractura de escápula

Respuesta correcta: c. Disyunción acromioclavicular

Explicación: Es una disyunción o luxación acromioclavicular (DAC) clásica: dolor en la unión acromioclavicular. En este caso está desplazada, por el signo de la tecla de piano. - Tanto las luxaciones de hombro, como la fractura de clavícula se producen por el mismo mecanismo (caída a nivel, con golpe en el hombre), pero la luxación anterior tiene signo de la charretera y dolor en la articulación glenohumeral. La luxación posterior es más inespecífica, pero no afecta la unión acromioclavicular y suele quedar con el brazo en aducción y rotación interna (parecido a la posición púdica de la luxación posterior de cadera, solo

que acá es del húmero) y la apófisis coracoides se vuelve prominente. - La fractura de clavícula puede tener signo de la tecla de piano, pero tendría crépito óseo, dolor a la palpación de la clavícula u otro signo de fractura (aunque en realidad las fracturas de la zona distal de la clavícula pueden ser indistinguibles de una DAC. - Las fracturas de escápula son por golpes en la espalda (habitualmente directo y sugieren maltrato infantil). Tienen dolor en el dorso (donde está la escápula.

Fuente: Traumatología y ortopedia, cuestionario 7.4, P4

13. Un paciente sufre una caída de una escalera, cayendo apoyado sobre la extremidad superior izquierda, en extensión, evolucionando con intenso dolor en el codo, que impide cualquier movimiento y deformidad notable. Se solicitan radiografías de codo que se muestran a continuación (fuente: https://drreyesjacome- spine.com/2020/12/11/...). El diagnóstico más probable es:

a. Fractura de cúpula radial
b. Fractura suprancondílea de húmero
c. Luxación de codo
d. Fractura de olécranon
e. Fractura de apófisis coronoides

Respuesta correcta: b. Fractura suprancondílea de húmero

Explicación: Tanto por la clínica (dolor intenso, deformación y equimosis en la fosa cubital), como por la radiografía, tiene una fractura supracondílea de húmero (del húmero distal). Suelen ser bastante complicadas, por lo que siempre se deben operar.

Fuente: Traumatología y ortopedia, cuestionario 7.4, P7

14. ¿Qué alteración haría sospechar una lesión del nervio axilar en un paciente con una luxación anterior de hombro?

a. Imposibilidad de flectar el codo y anestesia en la cara anterior del brazo
b. Imposibilidad de extender el codo y anestesia en la cara posterior del brazo
c. Imposibilidad de abducir el hombro y anestesia en la zona deltoidea
d. Imposibilidad de flectar la muñeca y anestesia en la cara anterior del antebrazo
e. Imposibilidad de extender la muñeca y anestesia en la cara posterior del antebrazo

Respuesta correcta: c. Imposibilidad de abducir el hombro y anestesia en la zona deltoidea

Explicación: El nervio axilar inerva la piel sobre el deltoides y además inerva al deltoides mismo, que abduce el hombro. La B y la E son lesiones del nervio radial. La D es lesión del nervio mediano (no la clásica).

Fuente: Traumatología y ortopedia, cuestionario 7.4, P9

15. Un paciente de 20 años recibe un pelotazo en la mano derecha, con hiperextensión del dedo medio. Evoluciona con intenso dolor, aumento de volumen y equimosis en relación a la articulación interfalánfica proximal de dicho dedo. La conducta más adecuada es:

a. Solicitar radiografía
b. Solicitar ecografía
c. Indicar inmovilizador de dedo, sin necesidad de imágenes
d. Indicar reposo, analgésicos y AINEs, sin necesidad de imágenes
e. Indicar kinesioterapia motora del dedo

Respuesta correcta: a. Solicitar radiografía

Explicación: Lo más probable es que sufrió un esguince de dedo, pero es obligatorio descartar las fracturas, con una radiografía, dado que tiene equimosis y dolor.

Fuente: Traumatología y ortopedia, cuestionario 7.4, P13

16. Un paciente presenta una fractura de húmero, la que es manejada ortopédicamente con yeso y posteriormente con un cabestrillo. Usted lo controla 2 meses después ya casi sin dolor, pero se aprecia movilidad anormal en el tercio medio del brazo, por lo que solicita una radiografía que muestra psudoartrosis con extremos óseos en "pata de elefante", con interposición de partes blandas. La conducta más adecuada es:

a. Retirar el cabestrillo y observar evolución
b. Resolver quirúrgicamente
c. Inmovilizar nuevamente con valva de yeso
d. Indicar kinesioterapia motora
e. Solicitar resonancia magnética nuclear

Respuesta correcta: b. Resolver quirúrgicamente

Explicación: La pseudoartrosis o no unión requiere de cirugía, ya que las partes blandas que se interponen entre los extremos óseos impiden completamente la consolidación. A grandes rasgos, la cirugía consiste en remover las partes blandas y tratar la causa de base. Vale la pena mencionar que, en este caso, se trata de una pseudoartrosis hipertrófica, causada por una mala inmovilización. La clásica excepción, que no se opera, es la espondilolisis, en que se separa el cuerpo vertebral de la lámina vertebral, pero las estructuras ligamentosas son suficientes para mantener la estabilidad.

Fuente: Traumatología y ortopedia, cuestionario 7.4, P17

17. Un paciente sufre una caída a nivel, golpeándose el hombro contra el suelo. Presenta importante dolor e impotencia funcional, por lo que se solicita una radiografía que muestra una luxación anterior de hombro. No se evidencian lesiones óseas y el examen no muestra alteraciones neurovasculares. La conducta más adecuada es:

a. Resolver quirúrgicamente de inmediato
b. Indicar ejercicios y AINEs
c. Reducción cerrada e inmovilización con cabestrillo bloqueado
d. Indicar reposo y AINEs
e. Solicitar TAC de hombro y decidir conducta según resultado

Respuesta correcta: c. Reducción cerrada e inmovilización con cabestrillo bloqueado

Explicación: La luxación de hombro se trata con reducción cerrada y posterior inmovilización con un inmovilizador de hombro. Si recurre, se debe tratar quirúrgicamente. Ninguna de las técnicas de reducción ha demostrado ser mejor que las otras. Tampoco los distintos tipos de inmovilización han demostrado superioridad.

Fuente: Traumatología y ortopedia, cuestionario 7.4, P18

18. ¿Cuál de las siguientes fracturas puede ser considerada osteoporótica?

a. Fractura de muñeca
b. Fractura de clavícula
c. Fractura de pierna
d. Fractura de tobillo

e. Fractura de antebrazo

Respuesta correcta: a. Fractura de muñeca

Explicación: Las fracturas causadas por la osteoporosis son: vertebrales, muñeca, cadera y subcapital de húmero.

Fuente: Traumatología y ortopedia, cuestionario 7.4, P20

19. Un hombre de 18 años sufre una caída de altura, cayendo con apoyo de las extremidades superiores. Presenta gran dolor en relación al codo derecho, con equimosis en la fosa cubital. Se solicita una radiografía que se muestra a continuación: El diagnóstico más probable es:



a. Fractura supracondílea de húmero
b. Fractura de apófisis coronoides
c. Luxación de codo
d. Fractura de olécranon
e. Fractura de cúpula radial

Respuesta correcta: a. Fractura supracondílea de húmero

Explicación: Tanto, por la clínica, como por la imagen, se trata de una fractura supracondílea de húmero.

Fuente: Traumatología y ortopedia, cuestionario 7.5, P2

20. ¿Qué estructura se suele dañar, en asociación con la lesión mostrada en la radiografía?

a. Nervio axilar
b. Arteria braquial
c. Nervio radial
d. Arteria circunfleja
e. Nervio cubital

Respuesta correcta: a. Nervio axilar

Explicación: Tiene una luxación anterior de hombro, la que se asocia a lesión del nervio axilar o circunflejo. También puede lesionar las arterias circunflejas anterior y posterior, pero lo más frecuente es la lesión del nervio. La arteria braquial se lesiona en las fracturas supracondíleas de húmero. El nervio radial, en las fracturas de diáfisis humeral. El nervio cubital, en las fracturas de codo.

Fuente: Traumatología y ortopedia, cuestionario 7.5, P15

Fracturas y luxaciones del miembro inferior y pelvis (10)

21. Una paciente de 68 años, presenta una caída a nivel, con golpe en el costado derecho. Presenta imposibilidad de pararse y de levantar el talón. Al examen físico está recostada, en la posición que se observa en la fotografía ((fuente: http://revistas.uach.cl/html/cuadcir/v22n1/body/art11.htm)). El diagnóstico más probable es:

a. Fractura de tobillo
b. Fractura de cadera
c. Luxación de cadera
d. Esguince de rodilla
e. Rotura del tendón de Aquiles

Respuesta correcta: b. Fractura de cadera

Explicación: La imagen muestra la posición impúdica, clásica de la fractura de cadera. Además, la clínica es la característica. Recordar que la luxación posterior de cadera tiene la posición púdica (acortamiento, aducción y rotación interna).

Fuente: Traumatología y ortopedia, cuestionario 7.1, P12

22. Un paciente sufre una luxofractura posterior de cadera, resultando con daño del nervio ciático. Clínicamente se presentará

a. Imposibilidad de extender la rodilla
b. Ausencia de sensibilidad de la cara lateral del muslo
c. Incontinencia urinaria
d. Imposibilidad de mover los ortejos
e. Signo de Babinsky

Respuesta correcta: d. Imposibilidad de mover los ortejos

Explicación: El nervio ciático tiene la sensibilidad de la cara posterior del muslo y de toda la pierna y el pie. Además, se encarga de la flexión de la rodilla y de todos los movimientos del tobillo, pie y ortejos, así como del reflejo rotuliano. La extensión de la rodilla la realiza el nervio femoral. La sensibilidad de la cara lateral del muslo está dada por el nervio cutáneo femoral lateral (o femorocutáneo). La continencia urinaria está dada por el nervio pudendo. El signo de Babinsky solo se da en lesiones del sistema nervioso central (médula o encéfalo), ya que es patognomónico del signo piramidal. En cambio, la lesión del nervio ciático producirá un síndrome de denervación o de segunda motoneurona.

Fuente: Traumatología y ortopedia, cuestionario 7.1, P16

23. Un paciente sufre una torcedura de tobillo mientras jugaba fútbol, presentado intenso dolor, que le impide caminar e incluso apoyar el pie. Al examen físico se aprecia equimosis en la zona externa del tobillo y pie y la compresión de los maléolos es muy dolorosa. El diagnóstico más probable es:

a. Luxación de tobillo
b. Fractura de tobillo

c. Esguince de tobillo grado II
d. Esguince de tobillo grado III
e. Luxación astrágalo-calcánea

Respuesta correcta: b. Fractura de tobillo

Explicación: Por el mecanismo y por la equimosis, puede ser tanto un esguince, como una fractura. Sin embargo, la imposibilidad de caminar y el dolor a la compresión maleolar son indicativos de fractura.

Fuente: Traumatología y ortopedia, cuestionario 7.3, P4

24. Un paciente sufre una luxación posterior de cadera izquierda en un accidente automovilístico. Al examen se constata anestesia e imposibilidad de realizar movimientos con el pie izquierdo. La estructura lesionada es:

a. Nervio femoral
b. Cauda equina
c. Nervio ciático
d. Raíz nerviosa L5
e. Raíz nerviosa S1

Respuesta correcta: c. Nervio ciático

Explicación: La luxofractura posterior de cadera suele lesionar el nervio ciático. Además, dicho nervio se encarga de la movilidad y sensibilidad por la cara posterior del muslo y por debajo de la rodilla (tanto anterior, como posterior).

Fuente: Traumatología y ortopedia, cuestionario 7.3, P8

25. Un paciente de 85 años sufre una caída a nivel, resultando con imposibilidad de caminar e intenso dolor en la zona inguinal. Al examen físico se aprecia posición impúdica y no puede despegar el talón del suelo. El diagnóstico más probable es:

a. Luxación anterior de cadera
b. Luxación posterior de cadera
c. Fractura de cadera
d. Fractura de diáfisis femoral
e. Fractura de cotilo

Respuesta correcta: c. Fractura de cadera

Explicación: La posición impúdica (abducción, acortamiento y rotación externa) es característica de la fractura de cadera. También el mecanismo de caída a nivel y la imposibilidad de levantar el talón del suelo. La luxación posterior, en cambio, tiene posición púdica (aducción, acortamiento y rotación interna). La luxación anterior sí puede tener posición impúdica, pero no se produce por caída a nivel, sino por abducción forzada.

Fuente: Traumatología y ortopedia, cuestionario 7.3, P9

26. La complicación más frecuente de las fracturas del astrágalo es:

a. Artrosis
b. Necrosis avascular
c. Infección
d. Trombosis venosa profunda

e. Consolidación viciosa

Respuesta correcta: b. Necrosis avascular

Explicación: Las fracturas de cuello femoral, de escafoides y de astrágalo se complican con necrosis avascular.

Fuente: Traumatología y ortopedia, cuestionario 7.3, P19

27. Un paciente es atropellado, resultando con una fractura de pelvis desplazada. Evoluciona con hipotensión y taquicardia. La conducta más adecuada es:

a. Administrar suero fisiológico endovenoso y realizar laparotomía de urgencia
b. Administrar suero fisiológico y observar evolución
c. Administrar suero fisiológico y realizar colonoscopía de urgencia
d. Administrar suero fisiológico y realizar reducción cerrada de la fractura, con férula neumática
e. Administrar suero fisiológico y realizar sinficiotomía púbica de urgencia

Respuesta correcta: d. Administrar suero fisiológico y realizar reducción cerrada de la fractura, con férula neumática

Explicación: Tiene una fractura de pelvis, complicada por un shock hipovolémico. Habitualmente es por rotura de las venas pélvicas y el tratamiento consiste en reponer fluidos y estabilizar la fractura de manera externa (con férula neumática, tutores externos, hamaca pélvica, o por último una sábana, si es que no están disponibles los demás elementos. Eso sí, en especial si hay traumatismo abdominal concomitante, en el paciente hemodinámicamente inestable se recomienda actualmente realizar una ecografía de urgencia, para descartar una causa abdominal del shock, que requiera laparotomía de urgencia. Sin embargo, el enunciado da a entender que se está preguntado el manejo clásico de la fractura de pelvis desplazada con hipotensión, en la que estabilizar la pelvis es lo más importante (además, como en todo shock hipovolémico, dar fluidos es lo más urgente).

Fuente: Traumatología y ortopedia, cuestionario 7.4, P12 · Traumatología y ortopedia, cuestionario 7.5, P20

28. Un paciente de 70 años sufre una caída a nivel, resultando con una fractura de cadera derecha, de tipo intertrocantérica, no desplazada (Tronzo 2). ¿Cuál de las siguientes alternativas es mejor para el manejo de este paciente?

a. Yeso pelvipedio
b. Reposo absoluto en cama, sin necesidad de inmovilizar
c. Osteosíntesis con tornillo dinámico
d. Prótesis parcial de cadera
e. Prótesis total de cadera

Respuesta correcta: c. Osteosíntesis con tornillo dinámico

Explicación: La fractura de cadera siempre se trata con cirugía. Sin embargo, la cirugía varía según el tipo de fractura. La regla general es la osteosíntesis, con tornillo dinámico de cadera (DHS), en las intertrocantéricas y con un tornillo canulado, en las fracturas de cuello femoral. Si, en cambio, hay necrosis avascular o un riesgo demasiado alto de necrosis avascular (mayor de 65 años, con fractura de cuello desplazada), se indica la prótesis parcial de cadera. Si además hay daño en el cotilo, se indica la prótesis total de cadera. Eso sí, hay quienes prefieren conservar la cadera original siempre y solo indican las prótesis si es que se produce efectivamente la necrosis avascular o si existe alguna otra indicación de reemplazo articular (ej. artrosis severa).

Fuente: Traumatología y ortopedia, cuestionario 7.4, P19

29. Una paciente de 68 años, presenta una caída a nivel, con golpe en el costado derecho. Presenta imposibilidad de pararse y de levantar el talón derecho. Al examen físico está recostada, en la posición que se observa en la fotografía. Mueve normalmente la extremidad izquierda. El diagnóstico más probable es:

a. Fractura de pelvis
b. Fractura de cadera
c. Luxación posterior de cadera
d. Necrosis avascular de la cabeza femoral
e. Rotura del tendón Rotuliano

Respuesta correcta: c. Luxación posterior de cadera

Explicación: Está en posición púdica, lo que es característico de la luxación posterior de cadera.

Fuente: Traumatología y ortopedia, cuestionario 7.5, P11

30. Las fracturas de cuello femoral tiene alto riesgo de:

a. Síndrome compartimental
b. Pseudoartrosis
c. Embolia grasa
d. Necrosis avascular
e. Lesión del nervio ciático

Respuesta correcta: d. Necrosis avascular

Explicación: Las fracturas que se complican con necrosis avascular son: 1. Escafoides, 2. Astrágalo y 3. Cadera, en especial las de cuello.

Fuente: Traumatología y ortopedia, cuestionario 7.5, P18

Fracturas expuestas y politraumatizado (9)

31. Un paciente de 45 años se realiza un corte con una lata, mientras realizaba faenas agrícolas. De niño recibió sus vacunas normalmente, según el esquema del plan nacional de inmunizaciones vigente esos años, que incluía la vacuna antitetánica en la vacuna triple o DPT. La conducta más adecuada respecto a la vacunación antitetánica es:

a. No debe recibir la vacunación antitetánica
b. Debe recibir una dosis de la vacuna antitetánica
c. Debe recibir una dosis de la vacuna antitetánica más inmunoglobulina antitetánica
d. Debe recibir el esquema completo, con al menos 3 dosis de la vacuna antitetánica
e. Debe recibir el esquema completo, con al menos 3 dosis de la vacuna antitetánica más inmunoglobulina antitetánica

Respuesta correcta: b. Debe recibir una dosis de la vacuna antitetánica

Explicación: Las recomendaciones de vacuna antitetánica varían según la fuente que se revise, pero la más utilizada es la siguiente: - Herida limpia y esquema completo: vacunar si han pasado más de 10 años. - Herida sucia y esquema incompleto: vacunar si han pasado más de 5 años. - Herida limpia y esquema incompleto: completar esquema. - Herida sucia y esquema incompleto: completar esquema + IgG antitetánica endovenosa. Los nacidos antes de 1975 generalmente no recibieron las vacunas cuando niños. Esquema desconocido se maneja como incompleto.

Fuente: Traumatología y ortopedia, cuestionario 7.1, P11

32. Un paciente sufre un accidente laboral, con una máquina de construcción, resultando con fractura del antebrazo derecho, con disrupción de los tegumentos. Presenta anestesia y plejia de los dedos, asociado a palidez y ausencia de pulso en la mano. ¿Qué tratamiento antibiótico es el más adecuado para el manejo de este paciente?

a. No requiere tratamiento antibiótico
b. Cefazolina más gentamicina
c. Cloxacilina
d. Penicilina más gentamicina
e. Clindamicina más metronidazol

Respuesta correcta: b. Cefazolina más gentamicina

Explicación: Tiene una fractura expuesta, por lo que requiere aseo quirúrgico con abundante suero fisiológico y antibióticos endovenosos. Si bien el esquema antibiótico varía según la fuente que se revise, las recomendaciones internacionales sugieren lo siguiente: - Grado I y II: cefazolina por 1 día. - Grado III: cefazolina + gentamicina por 3 días. - Si se contamina con tierra: agregar cobertura para anaerobios (ej. metronidazol). - Si se contamina con agua y es grado III: agregar cobertura para pseudomona (ej. imipenem o piperacilina + tazobactam).

Fuente: Traumatología y ortopedia, cuestionario 7.1, P13

33. Un paciente sufre un accidente de tránsito, con golpe en el antebrazo izquierdo. Usted lo evalúa y se aprecia con una herida contusa en el antebrazo izquierdo, que sangra activamente. Su PA es 100/60 mmHg y su FC es 90x'. Además de instalar una vía venosa y administrar cristaloides, la conducta inicial más adecuada es:

a. Resolver quirúrgicamente
b. Realizar ligadura arterial
c. Instalar una férula neumática
d. Comprimir la herida
e. Aplicar un torniquete

Respuesta correcta: d. Comprimir la herida

Explicación: El tratamiento de las hemorragias traumáticas es primeramente la compresión con paños limpios, más la reposición de volumen por vía venosa.

Fuente: Traumatología y ortopedia, cuestionario 7.1, P20

34. ¿Cuál de los siguientes signos clínicos es de peor pronóstico en un paciente con una fractura expuesta de antebrazo?

a. Anestesia, plejia, palidez y ausencia de pulso en la mano
b. Presencia de restos vegetales
c. Tiempo de evolución mayor a 6 horas
d. Etiología por arma de fuego
e. Herida mayor a 5 cm

Respuesta correcta: a. Anestesia, plejia, palidez y ausencia de pulso en la mano

Explicación: La anestesia y plejia dan cuenta de lesión neurológica y la palidez y ausencia de pulso son de lesión arterial. La afectación neurovascular es de mal pronóstico (grado III C). Los restos vegetales, la

evolución mayor de 6 horas, la etiología por arma de fuego y una herida mayor a 10 cm, todas son indicador de gravedad (grado III), pero ninguna es tan grave como la sección neurovascular.

Fuente: Traumatología y ortopedia, cuestionario 7.2, P8

35. Un paciente de 38 años sufre un accidente de tránsito, con fractura expuesta de a pierna izquierda. La cobertura de partes blandas es adecuada. La primera medida a realizar es:

a. Administrar antibióticos endovenosos
b. Aseo con abundante suero fisiológico
c. Administrar vacuna antitetánica
d. Derivar urgentemente a centro especializado
e. Administrar analgésicos endovenosos

Respuesta correcta: b. Aseo con abundante suero fisiológico

Explicación: Es una pregunta discutible, ya que hay algunos estudios que dicen que lo más importante y con mayor impacto es la administración de antibióticos endovenosos de manera precoz. Sin embargo, lo clásico y lo que hay que marcar, es que la primera medida es el aseo con abundante suero fisiológico, a chorro.

Fuente: Traumatología y ortopedia, cuestionario 7.2, P11

36. Un paciente sufre un accidente laboral, al caer en una zanja, mientras se desempeñaba como trabajador agrícola. Resulta con fractura expuesta del fémur derecho. Al examen se constata una herida de 7 cm de diámetro, con abundantes restos de tierra y vegetales. No hay compromiso nervioso ni vascular. ¿Cuál de las siguientes alternativas está MENOS indicada en este paciente?

a. Realizar aseo inmediato con abundante suero fisiológico
b. Administrar la vacuna antitetánica
c. Administrar cefazolina, gentamicina y metronidazol por vía endovenosa
d. Inmovilizar con una valva de yeso cerrada, compresiva
e. Una vez estabilizado y realizado el manejo inicial, debe ser derivado para resolución quirúrgica definitiva

Respuesta correcta: d. Inmovilizar con una valva de yeso cerrada, compresiva

Explicación: Tiene una fractura expuesta grado III (por los restos vegetales y por ocurrir en zona agrícola). Se trata con aseo con suero, antibióticos, AINEs, vacunación antitetánica y finalmente aseo quirúrgico, con reducción y osteosíntesis. Si se traslada, debe hacerse con valvas abiertas (para evitar el síndrome compartimental) y largas (para mejorar la inmovilización y reducir el dolor).

Fuente: Traumatología y ortopedia, cuestionario 7.3, P10

37. ¿Cuál de las siguientes opciones le da un peor pronóstico a un paciente con una fractura expuesta?

a. Tiempo de evolución de 7 horas
b. Mecanismo por bala
c. Presencia de tierra y restos vegetales en la herida
d. Sección neurovascular
e. Herida de 5 cm de largo

Respuesta correcta: d. Sección neurovascular

Explicación: La afectación neurovascular es mal pronóstico (grado III C). Los restos vegetales, la evolución mayor de 6 horas, la etiología por arma de fuego y una herida mayor a 10 cm, todas son indicador de gravedad (grado III), pero ninguna es tan grave como la sección neurovascular.

Fuente: Traumatología y ortopedia, cuestionario 7.4, P10

38. ¿Cuál de las siguientes acciones debe realizarse en primer lugar ante un paciente politraumatizado?

a. Solicitar radiografía de pelvis, tórax y cuello
b. Instalar vía venosa periférica
c. Poner collar cervical
d. Solicitar TAC de cerebro
e. Realizar una completa y detallada anamnesis y examen físico

Respuesta correcta: c. Poner collar cervical

Explicación: El tratamiento del paciente politraumatizado es el ABC. A: vía aérea y collar cervical; B: ventilación; C: vía venosa, suero y compresión de las heridas; D: buscar déficit neurológico; E: exponer.

Fuente: Traumatología y ortopedia, cuestionario 7.4, P11

39. ¿Cuál de las siguientes alteraciones tiene peor pronóstico en un paciente que sufre una fractura expuesta de antebrazo?

a. Causada por arma de fuego
b. Contaminación con tierra y restos vegetales
c. Herida de 10 cm de largo
d. 6 horas de evolución al momento de la primera atención
e. Pérdida significativa de las partes blandas

Respuesta correcta: e. Pérdida significativa de las partes blandas

Explicación: La afectación de partes blandas es de mal pronóstico (grado III B). Los restos vegetales, la evolución mayor de 6 horas, la etiología por arma de fuego y una herida mayor a 10 cm, y la evolución mayor a 6 horas todas son indicador de gravedad (grado III), pero ninguna es tan grave como la afectación de partes blandas (IIIB), ni la sección neurovascular (IIIC).

Fuente: Traumatología y ortopedia, cuestionario 7.5, P16

Complicaciones de las fracturas (13)

40. Un paciente sufre un accidente en bicicleta, resultando con una fractura de pierna (diáfisis de la tibia y el peroné) izquierda. Se confirma con la radiografía y se decide resolver con cirugía, sin embargo, a la espera de pabellón, evoluciona con intenso dolor de la pierna. Al examen físico se aprecia edema de la pierna, equimosis y gran dolor al movimiento de los ortejos. El diagnóstico más probable es:

a. Síndrome compartimental
b. Distrofia simpático refleja
c. Lesión de la arteria poplítea
d. Trombosis venosa profunda
e. Embolia grasa

Respuesta correcta: a. Síndrome compartimental

Explicación: Es un síndrome compartimental clásico: dolor intenso y desproporcionado a las pocas horas de la fractura, que aumenta con la movilización distal. Además, suele tener edema y puede tener

disminución de los pulsos. El diagnostico es clínico (aunque se puede objetivar con medición de la presión intracompartimental, mediante punción. El manejo es urgente y requiere de remoción de férulas, yesos, etc. más la inmediata descompresión quirúrgica mediante fasciotomía. - La distrofia simpático-refleja tiene dolor urente, con alodinia, asociado a cambios tróficos de piel, osteoporosis moteada y puede tener edema y eritema. Sí puede y suele tener dolor al movimiento distal. - La lesión arterial tiene palidez, pulso ausente, paresia, parestesia, frialdad y dolor, pero sin edema. - La trombosis venosa profunda tiene dolor y edema, pero suele aparecer algunos días después de la fractura y tiene dolor a la palpación de las masas musculares. - La embolia grasa tiene disnea (edema pulmonar no cardiogénico), petequias y compromiso de conciencia, que puede evolucionar a coma.

Fuente: Traumatología y ortopedia, cuestionario 7.1, P4

41. Un paciente presenta un accidente de tránsito, resultando con una fractura de pierna derecha. Es manejada con osteosíntesis, con placa y tornillos. Usted lo evalúa 6 meses después y se aprecia movilidad en el foco de fractura, sin dolor al realizar dicho movimiento. El diagnóstico más probable es:

a. Mala unión
b. Pseudoartrosis
c. Osteomielitis
d. Retraso en la consolidación
e. Atrofia ósea de Suddeck

Respuesta correcta: b. Pseudoartrosis

Explicación: Tiene una no unión o pseudoartrosis clásica, en la que las partes blandas se interponen entre los extremos de la fractura, por lo que ya no consolida y se presenta movilidad anormal en la zona, habitualmente ya sin dolor. En los casos en que no genera mayores molestias (ej. espondilolisis) se puede observar. En los demás, requiere tratamiento quirúrgico. - La mala unión, en cambio, sí consolida, pero con desviación, por lo que hay deformación e impotencia funcional, también sin dolor, pero sin movilidad, puesto que ya consolidó. - La osteomielitis presenta dolor, fiebre y signos inflamatorios. - El retraso en la consolidación persiste con dolor por un tiempo mayor al normal, ya que el proceso de consolidación está retrasado, pero avanzando. - La atrofia ósea de Suddeck o distrofia simpático-refleja se caracteriza por dolor tipo neuropático, asociado a cambios tróficos de piel y fanéreos (ej. caída de los vellos o cambios en el grosor o color de la piel).

Fuente: Traumatología y ortopedia, cuestionario 7.1, P10

42. Un paciente de 40 años sufre un accidente en motocicleta, resultando con fractura de pierna, la que maneja con osteosíntesis con una placa. Se le prohíbe apoyar la extremidad, sin embargo, no cumple completamente las indicaciones. Usted lo recibe 3 meses después, sin dolor, pero se aprecia consolidación de la fractura, con desviación en varo marcada de la zona distal a la fractura. El diagnóstico es:

a. Pseudoartrosis
b. Retraso de la consolidación
c. Atrofia ósea de Suddeck
d. Mala unión
e. Artrosis

Respuesta correcta: d. Mala unión

Explicación: La mala unión o consolidación viciosa tiene consolidación, con desviación de los ejes. Deja de doler. La pseudoartrosis o no unión no consolida, por interposición de partes blandas, por lo que queda con movilidad anormal, aunque deja de doler también. El retraso en la consolidación demora más tiempo

del normal en consolidar, por lo que sigue doliendo, a pesar de que ya no debería doler. Tiene un callo óseo en maduración. La atrofia ósea de Suddeck o síndrome de dolor regional complejo tiene dolor tipo neuropático, asociado a cambios tróficos en la piel, fanéreos y huesos.

Fuente: Traumatología y ortopedia, cuestionario 7.2, P5

43. Un paciente sufre una fractura de muñeca con compromiso intrarticular, la que es manejada mediante cirugía, con reducción y osteosíntesis en pabellón. ¿Cuál es la razón por la que este tipo de fractura debió ser manejada quirúrgicamente?

a. Porque en caso contrario, desarrolla artrosis
b. Porque en caso contrario, desarrolla pseudoartrosis
c. Porque en caso contrario, desarrolla consolidación viciosa
d. Porque en caso contrario, desarrolla osteomielitis
e. Porque en caso contrario, desarrolla síndrome del túnel carpiano

Respuesta correcta: a. Porque en caso contrario, desarrolla artrosis

Explicación: Las fracturas con rango intrarticular evolucionan con artrosis, si es que no logran una adecuada reducción y fijación quirúrgica.

Fuente: Traumatología y ortopedia, cuestionario 7.2, P9

44. Un paciente de 69 años sufre una fractura de cadera, la que es manejada quirúrgicamente. Al día siguiente presenta disnea de inicio súbito, asociado a desaturación arterial, hasta 85%. El examen pulmonar muestra algunos crépitos difusos, mayores en la base izquierda. El diagnóstico más probable es:

a. Embolia grasa
b. Tromboembolismo pulmonar
c. Embolia séptica
d. Anemia severa
e. Distrofia simpático refleja

Respuesta correcta: b. Tromboembolismo pulmonar

Explicación: Es un TEP clásico: disnea, dolor y/o desaturación súbita, en relación a una situación de riesgo (en este caso la fractura). La embolia grasa tiene una triada: distrés respiratorio (edema pulmonar agudo), rash petequial y compromiso de conciencia.

Fuente: Traumatología y ortopedia, cuestionario 7.2, P13

45. Un paciente de 18 años sufre una fractura cerrada de fémur, la que se hospitaliza en espera de cirugía. Evoluciona a las pocas horas con dolor mucho más intenso, que aumenta especialmente al realizar estiramiento pasivo de la rodilla. Se aprecia edema importante de la extremidad. El diagnóstico más probable es:

a. Trombosis venosa profunda
b. Fasceítis necrotizante
c. Síndrome compartimental
d. Embolia grasa
e. Distrofia simpático refleja

Respuesta correcta: c. Síndrome compartimental

Explicación: Es un síndrome compartimental clásico: dolor intenso, que aumenta al estiramiento pasivo distal, más edema (puede tener disminución del pulso), que ocurre al poco tiempo de una fractura. Se

diagnostica con la clínica (solo en casos excepcionales se mide la presión del compartimento). El tratamiento es urgente y requiere remover férulas y yesos, elevar la mano y proceder cuanto antes a la fasciotomía quirúrgica. - La TVP habría empezado algunos días después y puede tener edema y dolor, pero que aumenta al palpar las masas musculares y al dorsiflectar el pie (signo de Homans). - La fasceítis también duele mucho, pero tendría zonas violáceas o necróticas en la piel y fiebre u otro signo de infección. - La embolia grasa tiene distrés respiratorio, petequias y compromiso de conciencia. - La distrofia simpático-refleja puede tener edema y dolor, que aumenta al estiramiento distal, pero ocurre algunas semanas después y tiene dolor neuropático, asociado a cambios tróficos de la piel y huesos.

Fuente: Traumatología y ortopedia, cuestionario 7.2, P19

46. Un paciente sufre una fractura de húmero. Es manejado de manera ortopédica, sin cumplir cabalmente las indicaciones de reposo y uso de cabestrillo. Consulta 5 meses después, sin dolor, pero con movilidad anormal, a nivel del tercio medio del brazo. El diagnóstico más probable es:

a. Pseudoartrosis
b. Consolidación viciosa
c. Retraso de la consolidación
d. Osteomielitis
e. Necrosis avascular

Respuesta correcta: a. Pseudoartrosis

Explicación: La pseudoartrosis o no unión no consolida, por interposición de partes blandas, por lo que queda con movilidad anormal, aunque deja de doler también. Se debe estudiar con una radiografía. La mala unión o consolidación viciosa tiene consolidación, con desviación de los ejes. Deja de doler. El retraso en la consolidación demora más tiempo del normal en consolidar, por lo que sigue doliendo, a pesar de que ya no debería doler. Tiene un callo óseo en maduración.

Fuente: Traumatología y ortopedia, cuestionario 7.3, P5

47. Un paciente de 48 años sufre una fractura de tobillo izquierdo, la que es manejada quirúrgicamente. Tres días después presenta dolor moderado, edema y eritema de la pierna izquierda. Al examen, presenta signos vitales normales y se constata dolor a la palpación de las masas musculares, sin alteraciones en el pulso, sensibilidad o movilidad distal. El diagnóstico más probable es:

a. Distrofia simpático-refleja
b. Síndrome compartimental
c. Trombosis venosa profunda
d. Celulitis
e. Osteomielitis

Respuesta correcta: c. Trombosis venosa profunda

Explicación: Es una TVP clásica: dolor, edema, eritema, más el dolor a la palpación de las masas musculares (también suele tener signo de Homans: dolor a la dorsiflexión del pie). La distrofia simpático-refleja o síndrome de dolor regional complejo aparece algunas semanas después y tiene dolor tipo urente, con alodinia, más cambios en la piel, fanéreos y huesos (osteoporosis moteada). Sí puede tener edema y eritema. El síndrome compartimental suele ocurrir solo algunos minutos después de la fractura y se caracteriza por dolor intenso, que aumenta con la movilidad distal pasiva. Además, suele tener edema.

Fuente: Traumatología y ortopedia, cuestionario 7.3, P7

48. Dos semanas después de haber sufrido una fractura de pierna, un paciente de 80 años presenta intenso dolor, con alodinia marcada. Se observa adelgazamiento de la piel de la pierna afectada y en la radiografía hay signos de osteoporosis con lesiones en sacabocado. El diagnóstico más probable es:

a. Distrofia simpático refleja
b. Osteomielitis aguda
c. Mieloma múltiple
d. Osteosarcoma
e. Metástasis óseas

Respuesta correcta: a. Distrofia simpático refleja

Explicación: Es una distrofia simpático-refleja clásica (o atrofia ósea de Suddeck o síndrome de dolor regional complejo). Se caracteriza por dolor tipo neuropático (alodinia, urente), más cambios tróficos en la piel y fanéreos, más lesiones óseas en sacabocado (osteoporosis moteada). Se trata con analgesia (ej. AINEs) y estabilizadores del dolor (gabapentina, pregabalina, tricíclicos). Para la osteoporosis, sirven los bifosfonatos.

Fuente: Traumatología y ortopedia, cuestionario 7.3, P18

49. Un paciente sufre una fractura segmentaria de la diáfisis humeral, la que es hospitalizada para cirugía. En espera de pabellón, evoluciona con dolor mucho más intenso que el inicial, en especial a la flexión y extensión pasiva del codo. Se aprecia edema y dolor del brazo. El diagnóstico más probable es:

a. Trombosis venosa profunda
b. Síndrome compartimental
c. Lesión del nervio radial
d. Distrofia simpático refleja
e. Lesión de la arteria braquial

Respuesta correcta: b. Síndrome compartimental

Explicación: Es un síndrome compartimental clásico: dolor intenso, que aumenta al estiramiento pasivo distal, más edema (puede tener disminución del pulso), que ocurre al poco tiempo de una fractura. La TVP habría empezado algunos días después y puede tener edema y dolor, pero que aumenta al palpar las masas musculares y al dorsiflectar el pie (signo de Homans). La lesión del nervio radial tendría imposibilidad de extender la muñeca y los dedos, con afectación de la sensibilidad de la zona posterior de la extremidad. La distrofia simpático-refleja puede tener edema y dolor, que aumenta al estiramiento distal, pero ocurre algunas semanas después y tiene dolor neuropático, asociado a cambios tróficos de la piel y huesos. La lesión de la arteria braquial tendría dolor (pain), palidez, pulso ausente, paresia, parestesia y poiquilotermia (frialdad), es decir, las 6P.

Fuente: Traumatología y ortopedia, cuestionario 7.4, P6

50. Un paciente sufre un accidente en bicicleta, resultando con una fractura de pierna izquierda, la que es manejada de manera quirúrgica. Consulta dos semanas después por aumento del dolor. Al examen físico se aprecia edema de la extremidad, con dolor a la palpación de las masas musculares y eritema. El diagnóstico más probable es:

a. Síndrome compartimental
b. Distrofia simpático refleja
c. Lesión de la arteria poplítea
d. Trombosis venosa profunda

e. Embolia grasa

Respuesta correcta: d. Trombosis venosa profunda

Explicación: Es una TVP clásica, tanto por el tiempo de evolución (suele iniciar desde el día 2, hasta la consolidación completa), como por la clínica clásica: dolor que aumenta al palpar las masas musculares, más edema y eritema o coloración cianótica. La distrofia simpático-refleja puede tener dolor, edema y eritema, pero además tiene cambios tróficos en la piel o hueso (osteoporosis moteada), más un dolor de tipo neuropático (urente, con alodinia). El síndrome compartimental suele ocurrir a las pocas horas de la fractura. La lesión arterial también es aguda y se caracteriza por las 6P (pain, paresia, parestesia, palidez, poiquilotermina y pulso ausente). La embolia grasa tiene distrés respiratorio, rash petequial y compromiso de conciencia.

Fuente: Traumatología y ortopedia, cuestionario 7.5, P4

51. Un paciente presenta una fractura de húmero, la que se maneja ortopédicamente, con cabestrillo bloqueado. Tres meses después, evolucionan con clara disminución del dolor, sin embargo, presenta movilidad anormal en el tercio medio del brazo. Se solicita una radiografía de brazo, que muestra el foco de fractura con material radiolúcido entre los extremos óseos, que se aprecian hipertróficos, “en pata de elefante”. El diagnóstico más probable es:

a. Mala unión
b. Pseudoartrosis
c. Osteommielitis
d. Retraso en la consolidación
e. Atrofia ósea de Suddeck

Respuesta correcta: b. Pseudoartrosis

Explicación: Tiene una no unión o pseudoartrosis clásica, en la que las partes blandas se interponen entre los extremos de la fractura, por lo que ya no consolida y se presenta movilidad anormal en la zona, habitualmente ya sin dolor. En este caso, además, es de tipo hipertrófica (por los extremos en “pata de elefante”), producida por una mala inmovilización. - La mala unión, en cambio, sí consolida, pero con desviación, por lo que hay deformación e impotencia funcional, también sin dolor, pero sin movilidad, puesto que ya consolidó. - La osteomielitis presenta dolor, fiebre y signos inflamatorios. - El retraso en la consolidación persiste con dolor por un tiempo mayor al normal, ya que el proceso de consolidación está retrasado, pero avanzando. - La atrofia ósea de Suddeck o distrofia simpático-refleja se caracteriza por dolor tipo neuropático, asociado a cambios tróficos de piel y fanéreos (ej. caída de los vellos o cambios en el grosor o color de la piel), más osteoporosis "moteada".

Fuente: Traumatología y ortopedia, cuestionario 7.5, P10

52. Un paciente de 35 años sufre un accidente laboral, sufriendo un aplastamiento de algunos dedos de la mano izquierda, con una máquina compresora. Al examen físico se aprecia herida contusa en los dedos índice y medio izquierdos, con escaso sangrado y que permite observar el hueso de las falanges. La radiografía demuestra la presencia de fractura conminuta de ambos dedos. ¿Cuál de las siguientes opciones es la MENOS adecuada para el manejo inicial de este paciente?

a. Administrar antibióticos endovenosos
b. Realizar aseo con abundante suero fisiológico
c. Administrar analgésicos
d. Administrar la vacuna antitetánica
e. Realizar fasciotomía amplia

Respuesta correcta: e. Realizar fasciotomía amplia

Explicación: Tiene una fractura expuesta, por lo que se debe manejar con todo lo indicado en las alternativas, excepto con la fasciotomía amplia, ya que esta es el manejo del síndrome compartimental. Además, es raro un síndrome compartimental en los dedos.

Fuente: Traumatología y ortopedia, cuestionario 7.5, P12

Lesiones ligamentosas, meniscales y tendíneas (7)

53. Un paciente de 32 años presenta torsión de rodilla derecha mientras jugaba fútbol. Evoluciona con intenso dolor y dificultades para caminar. Al examen físico presenta dolor en la cara medial de la rodilla derecha e inestabilidad, con signo del bostezo. El diagnóstico más probable es:

a. Lesión meniscal
b. Esguince de rodilla
c. Rotura del ligamento cruzado
d. Fractura de rodilla
e. Cuerpo libre intraarticular

Respuesta correcta: b. Esguince de rodilla

Explicación: Es una rotura clásica del ligamento colateral medial y por la inestabilidad u signo del bostezo, es una rotura completa. En otras palabras, es un esguince grado 3. Tanto las lesiones de ligamento colateral medial como de ligamento colateral lateral se diagnostican con la clínica, siendo útil la ecografía en caso de duda, pero, además, es habitual que se deba solicitar una resonancia magnética nuclear para descartar otras lesiones asociadas (ej. meniscales). Su tratamiento suele ser ortopédico y solo los casos que no responden se manejan con cirugía. - Las lesiones de menisco tienen alterada la maniobra de Appley. - La rotura de ligamento cruzado tiene signo del cajón e inestabilidad. - La fractura de rodilla tiene dolor óseo y además puede tener una hemartrosis con gotas de grasa (a diferencia de la hemartrosis por rotura de ligamentos). - El cuerpo libre articular tiene dolor intermitente y bloqueo articular.

Fuente: Traumatología y ortopedia, cuestionario 7.1, P3

54. Un paciente sufre una torsión del tobillo izquierdo, mientras bajaba escaleras, evolucionando con intenso dolor. Al examen se aprecia equimosis en la zona medial del tobillo y dolor a los movimientos de inversión forzada, lo que lo hacen cojear. El diagnóstico de sospecha es:

a. Esguince de tobillo
b. Fractura de tobillo
c. Luxación de tobillo
d. Contusión de tobillo
e. Hemartrosis

Respuesta correcta: a. Esguince de tobillo

Explicación: Es un esguince de tobillo clásico. Por el mecanismo, el dolor y la equimosis, también podría ser una fractura, por lo que hay que solicitar radiografías de tobillo, para descartarla. Sin embargo, la posibilidad de apoyar el pie y la ausencia de dolor a la compresión ósea, hace mucho más probable que sea un simple esguince.

Fuente: Traumatología y ortopedia, cuestionario 7.1, P17 · Traumatología y ortopedia, cuestionario 7.5, P17

55. Un paciente de 45 años presenta intenso dolor, de inicio súbito en el talón izquierdo, mientras jugaba fútbol, quedando con imposibilidad de realizar flexión plantar con ese pie. El diagnóstico más probable es:

a. Rotura del tendón de Aquiles
b. Lesión del nervio peroneo común
c. Lesión del nervio ciático
d. Fractura de calcáneo
e. Fractura de astrágalo

Respuesta correcta: a. Rotura del tendón de Aquiles

Explicación: Es una rotura clásica del tendón de Aquiles: dolor súbito muy intenso (signo del piedrazo o del latigazo), con imposibilidad de flectar el pie (no puede pisar el acelerador). Suele ser de causa degenerativa. Se diagnostica con la clínica y se debe operar.

Fuente: Traumatología y ortopedia, cuestionario 7.3, P14

56. Un paciente sufre varo forzado de la rodilla derecha, mientras hacía deporte, evolucionando con dolor en la rodilla. Al examen presenta dolor a la palpación de la zona lateral de la rodilla, en especial al realizar varo. La maniobra de Appley es negativa. El diagnóstico más probable es:

a. Lesión de menisco medial
b. Lesión de menisco lateral
c. Lesión de ligamento cruzado anterior
d. Tendinitis de la pata de ganso (tendinitis ansarina)
e. Esguince de rodilla, con lesión del ligamento colateral lateral

Respuesta correcta: e. Esguince de rodilla, con lesión del ligamento colateral lateral

Explicación: Es una lesión clásica del ligamento colateral lateral (LCL): mecanismo de varo forzado y dolor en la zona lateral. El tratamiento de primera línea suele ser ortopédico, como casi todo esguince. - La lesión de meniscos se produce por mecanismos de torsión y tienen la maniobra de Appley positiva. - La lesión del ligamento cruzado anterior se produce por mecanismo de hiperextensión de la rodilla y tiene inestabilidad, con signo del cajón anterior.

Fuente: Traumatología y ortopedia, cuestionario 7.3, P15

57. Un paciente sufre una inversión forzada del tobillo izquierdo mientras trotaba. Evoluciona con intenso dolor con los movimientos del pie. Al examen físico se aprecia equimosis del área inframaleolar externa e inestabilidad del tobillo. Se solicitan radiografías de tobillo, que resultan normales. Se administran analgésicos y se eleva la extremidad. La conducta más adecuada es:

a. Resolver quirúrgicamente
b. Indicar ejercicios de caminata
c. Inmovilizar con bota ortopédica
d. Realizar punción articular
e. Solicitar resonancia magnética nuclear

Respuesta correcta: c. Inmovilizar con bota ortopédica

Explicación: Tiene un esguince de rodilla grado 3. No tiene fractura, porque las radiografías están normales y es un esguince grado 3, porque tiene inestabilidad. Se debe inmovilizar, ya sea con un yeso o con una bota removible (idealmente con esta última). Además, debe recibir AINEs, frío local y reposo.

Fuente: Traumatología y ortopedia, cuestionario 7.4, P1

58. Un paciente de 32 años presenta torsión de rodilla derecha mientras jugaba fútbol. Evoluciona con intenso dolor y dificultades para caminar. Al examen físico presenta dolor en la cara medial de la rodilla derecha e inestabilidad, con signo del bostezo. La maniobra de Appley es negativa. La radiografía descarta lesiones óseas. La conducta más adecuada para el manejo de la patología descrita es:

a. Indicar analgésicos y kinesioterapia motora, con ejercicios de fortalecimiento de cuádriceps
b. Indicar analgésicos y solicitar nueva radiografía en 2 semanas
c. Realizar artrocentesis y administrar corticoides intraarticulares
d. Indicar analgésicos e inmovilizar la rodilla
e. Resolver quirúrgicamente

Respuesta correcta: d. Indicar analgésicos e inmovilizar la rodilla

Explicación: Falta la resonancia magnética para confirmar la lesión ligamentosa y descartar la lesión meniscal (aunque la maniobra de Appley negativa sugiere que los meniscos están indemnes). Sin embargo, la clínica es muy sugerente de una lesión del ligamento colateral medial, en este caso, grado III, por el signo de bostezo, que da cuenta de una sección completa. Generalmente, se trata con manejo ortopédico (inmovilizador de rodilla), más analgésicos (al igual que todo esguince, puesto que es un esguince).

Fuente: Traumatología y ortopedia, cuestionario 7.5, P3

59. Un paciente de 30 años consulta por dolor en la rodilla derecha, que aparece al caminar y al hacer ejercicio. Se constata dolor a los movimientos de rotación externa en la rodilla, en posición semiflectada y la maniobra de Appley es dolorosa, en especial en rotación externa. ¿Qué examen es más adecuado para proseguir con el estudio?

a. Radiografía
b. Ecografía
c. Tomografía
d. Resonancia magnética
e. Contigrafía

Respuesta correcta: d. Resonancia magnética

Explicación: La clínica sugiere una lesión del menisco interno (duele la maniobra de Appley a la rotación externa). Se estudia con resonancia magnética nuclear.

Fuente: Traumatología y ortopedia, cuestionario 7.5, P8

Reumatismo de partes blandas y atrapamientos nerviosos (8)

60. Una mujer de 45 años consulta por dolor en el hombro derecho, que se produce al limpiar o realizar otros movimientos con la extremidad superior derecha. Además, refiere que el dolor aparece también en reposo, usualmente en la noche. Al examen físico es especialmente dolorosa la abducción contra resistencia. ¿Qué imagen es más adecuada para proseguir con el estudio en esta paciente?

a. Radiografía
b. Ecografía
c. Tomografía
d. Resonancia magnética
e. Contigrafía

Respuesta correcta: b. Ecografía

Explicación: El examen de elección para el estudio del hombro doloroso es la ecografía. Además, la sospecha diagnóstica es un síndrome de manguito rotador, que también se estudia con ecografía, como primera línea, ya que es el más costoefectivo. De segunda línea, puede ser la resonancia magnética nuclear.

Fuente: Traumatología y ortopedia, cuestionario 7.1, P8

61. Un paciente de 70 años consulta por dolor en la ingle derecha, que aumenta al caminar, lo que limita en cierta medida, sus actividades de la vida diaria. Se solicita radiografía de caderas, que muestra disminución del espacio articular y formación de osteofitos. Se inicia tratamiento con paracetamol y se controla 3 meses después. El paciente refiere que el dolor ha disminuido parcialmente, pero que persiste y aún limita algunas de sus actividades. La conducta más adecuada es:

a. Agregar AINEs
b. Solicitar TAC de cadera
c. Resolver quirúrgicamente
d. Solicitar tipificación para antígeno de histocompatibilidad HLA-B27
e. Mantener indicaciones

Respuesta correcta: a. Agregar AINEs

Explicación: Tiene una artrosis de cadera, tanto por la clínica (dolor inguinal), como por los hallazgos radiológicos. El tratamiento tiene como objetivo eliminar el dolor y se inicia con analgésico más ejercicios. - Históricamente, de elección ha sido el paracetamol oral (1g cada 8 horas), más baja de peso y ejercicios de fortalecimiento de cuádriceps (más útil en artrosis de rodilla, que de cadera). Lamentablemente, estudios actuales no identifican beneficios clínicamente relevantes con el paracetamol solo. Este sigue siendo el manejo de las guías ministeriales chilenas. -De segunda línea, se indican los AINEs (tanto COX1, como COX2 son útiles, aunque los COX2, como el celecoxib, tienen menos riesgo de úlceras y daño renal). Sin embargo, estudios recientes han demostrado que los AINEs son mejores que el paracetamol, por lo que podrían ir de primera línea. - Si persiste con dolor, o están contraindicados los AINES (ej. IRC), se agrega tramadol. Sin embargo, estudios actuales los desaconsejan, dado que tienen muchos efectos adversos (mareos, náuseas, caídas, dependencia). - Los corticoides intraarticulares son útiles, pero su eficacia es muy corta (1-2 meses), por lo que solo se usan para situaciones en que se requiere un alivio breve del dolor. - De última línea, se indica la cirugía de reemplazo articular (en cadera y rodilla), con buena respuesta, en la mayoría de los casos. * No sirven o no tienen evidencia el condroitín sulfato, la glucosamina y similares, el plasma rico en plaquetas o el ácido hialurónico intraarticulares y una larga lista de otras terapias. El paracetamol, según algunas recomendaciones, caería en esta lista.

Fuente: Traumatología y ortopedia, cuestionario 7.1, P19

62. Un paciente presenta dolor en la cara externa de la muñeca, en especial al realizar movimientos con la mano y el pulgar. Al examen se produce dolor al presionar la zona y especialmente al hiperflectar el pulgar y simultáneamente cubitalizar la muñeca. El diagnóstico más probable es:

a. Fractura de apófisis estiloides radial
b. Fractura de apófisis estiloides cubital
c. Artrosis de muñeca
d. Necrosis avascular de escafoides
e. Tendinitis de Quervain

Respuesta correcta: e. Tendinitis de Quervain

Explicación: Es una tendinitis de Quervain clásica, que afecta el tendón del abductor largo o el tendón del extensor corto del pulgar. Duele tanto al tocarlos, como al estirarlo (al flectar el pulgar y cubitalizar la mano). El diagnóstico es clínico y el tratamiento es con reposo (ej. con férula de pulgar) y AINEs. Los casos que no responden, se pueden tratar con corticoides inyectables. - Las fracturas tendrían antecedente de traumatismo. - La artrosis de muñeca es muy rara y en general es secundaria a fracturas previas. - La necrosis avascular tendría antecedente de traumatismo y dolor en la tabaquera anatómica, persistente en el tiempo.

Fuente: Traumatología y ortopedia, cuestionario 7.2, P2

63. Una paciente de 68 años consulta por debilidad de la mano derecha. Refiere que no tiene fuerza para sujetar las cosas con el pulgar, el índice y el dedo medio. Además, presenta parestesias en dichos dedos. El diagnóstico más probable es:

a. Atrapamiento cubital
b. Síndrome de túnel carpiano
c. Dedos en gatillo
d. Lesión del nervio radial
e. Tenosinovitis del tendón del músculo flexor superficial de los dedos

Respuesta correcta: b. Síndrome de túnel carpiano

Explicación: Es un síndrome de túnel carpiano clásico: debilidad y parestesias del pulgar, índice y dedo medio (además, puede afectar también la mitad del dedo anular). Se atrapa el nervio mediano. El atrapamiento cubital, en cambio, afecta al anular y al meñique. El dedo en gatillo se presenta como dificultad para extender algunos dedos, lo que luego saltan (también se llama “dedo en resorte”). La lesión del nervio radial produce dificultad en la extensión de los dedos y de la muñeca, así como en la sensibilidad de la cara posterior de la mano.

Fuente: Traumatología y ortopedia, cuestionario 7.2, P14

64. Una dueña de casa presenta dolor intenso en el codo, en especial al palpar la zona de inserción de los músculos flexores del antebrazo. El diagnóstico es:

a. Epitrocleítis
b. Epicondilitis
c. Tendinitis bicipital
d. Tendinitis tricipital
e. Tendinitis de Quervein

Respuesta correcta: a. Epitrocleítis

Explicación: La epitrocleítis o epicondilitis medial o codo del golfista, tiene dolor en la zona medial del codo (en el epicóndilo medial), que es donde se insertan los flexores. La epicondilitis o epicondilitis lateral o codo del tenista, tiene dolor en la zona de inserción de los extensores (epicóndilo lateral). Ambas se tratan con AINES, reposo relativo, KNT motora y la banda de descompresión. No es necesario pedir ningún examen, aunque ante la duda diagnóstica, podría usarse la ecografía (no sirven radiografía, TAC ni se suele usar la RMN, salvo excepciones). - La tendinitis bicipital distal, duele en la zona media de la cara anterior del codo. - La tendinitis tricipital duele proximal al olécranon, ya que ahí se inserta el tendón del tríceps. - La tendinitis de Quervain duele en la zona lateral de la muñeca y base del pulgar.

Fuente: Traumatología y ortopedia, cuestionario 7.3, P13

65. Un paciente presenta talalgia crónica, que aparece al caminar un par de cuadras. Los síntomas se han hecho más molestos en el último tiempo, por lo que decide realizarse una radiografía de pie, que muestra la presencia de un espolón calcáneo. La conducta más adecuada es:

a. Resolver quirúrgicamente
b. Solicitar Resonancia Magnética Nuclear de pie
c. Indicar calzado blando, plantillas de descarga y AINEs
d. Realizar infiltración local con corticoides
e. Inmovilizar con bota corta removible

Respuesta correcta: c. Indicar calzado blando, plantillas de descarga y AINEs

Explicación: El tratamiento de la talalgia, con y sin espolón calcáneo es igual: calzado cómodo y AINEs si está con mucho dolor.

Fuente: Traumatología y ortopedia, cuestionario 7.3, P16

66. Un paciente consulta por debilidad para tomar cosas con los dedos anular y meñique izquierdos, asociado a parestesias en dichos dedos. El diagnóstico más probable es:

a. Atrapamiento cubital
b. Atrapamiento radial
c. Atrapamiento del mediano
d. Dedos en gatillo
e. Retracción isquémica de Volkman

Respuesta correcta: a. Atrapamiento cubital

Explicación: Es un atrapamiento cubital clásico: parestesias y debilidad en la flexión del 4° y 5° dedos.

Fuente: Traumatología y ortopedia, cuestionario 7.4, P8

67. Una paciente presenta dificultad progresiva para extender el 4° dedo derecho, de 2 años de evolución, el que aumenta hasta la situación que se muestra en la fotografía y que no ha cedido con AINEs ni ejercicios: La conducta más adecuada es:

a. Solicitar TAC de dedo
b. Resolver quirúrgicamente
c. Solicitar electromiografía
d. Educar, en especial sobre cesar totalmente el consumo de alcohol
e. Indicar corticoides orales

Respuesta correcta: b. Resolver quirúrgicamente

Explicación: Tiene un “dedo en gatillo” o “dedo en resorte” clásico. Se produce por atrapamiento del tendón del flexor profundo de los dedos. Su diagnóstico es clínico. Su tratamiento en agudo suele seguir el siguiente orden: 1. AINEs y férula en mínima flexión por 4-6 semanas, 2. corticoides inyectados localmente y 3. resolución quirúrgica. En resumen, actualmente se recomienda intentar manejo conservador antes de la cirugía. Sin embargo, de las opciones, la única aceptable es la cirugía. El alcohol se correlaciona con la contractura de Dupuytren.

Fuente: Traumatología y ortopedia, cuestionario 7.5, P5

Ortopedia infantil (10)

68. Un niño de 8 años presenta cojera desde hace 2 semanas, que ha ido en aumento. No presenta dolor espontáneo. Al examen físico se aprecia en buenas condiciones generales y presenta dolor a la abducción y a la rotación externa de la cadera izquierda. El resto del examen físico es normal. La conducta más adecuada es:

a. Indicar AINES y observar evolución
b. Solicitar radiografía de pelvis AP
c. Solicitar ecografía de cadera
d. Solicitar resonancia magnética nuclear de cadera
e. Administrar antibióticos endovenosos y resolver quirúrgicamente

Respuesta correcta: b. Solicitar radiografía de pelvis AP

Explicación: La sospecha diagnóstica es una enfermedad de Perthes, la que se estudia con radiografía AP de pelvis. Por otro lado, es un niño que claudica, que se estudia inicialmente con radiografías (y dado que tiene dolor de caderas, se solicita radiografía AP de pelvis, que permite ver ambas caderas simultáneamente). - La enfermedad de Perthes afecta a niños entre 5 y 10 años (rango total: 2 a 13 años), con dolor en la cadera. Se asocia a talla baja y a antecedentes familiares. Suele tener una evolución más arrastrada e insidiosa. Algo importante es que estudios más recientes muestran que hay mucha superposición entre las edades de la sinovitis transitorias y la enfermedad de Legg Calvé Perthes (llamada actualmente osteonecrosis idiopática de la cabeza femoral), ya que ambas se presentan con cierta frecuencia entre los 3 y los 8 años (Perthes puede ser en mayores), por tanto, la principal diferencia entre ambas es el tiempo de evolución, ya que la sinovitis suele duran cerca de una semana (solo en pocos casos se alarga y se estudia), mientras que la enfermedad de Perthes suele ser más subaguda. Se diagnostica con la radiografía de caderas, aunque al inicio puede estar normal y ser necesaria una RMN. Se maneja ortopédicamente y, en casos graves, con cirugía.

Fuente: Traumatología y ortopedia, cuestionario 7.1, P1

69. Un niño de 14 años consulta por dolor inguinal izquierdo, que se irradia a la rodilla, de cerca de una semana de evolución. Ha empeorado considerablemente en el último tiempo, dificultándole la marcha. Al examen tiene dolor y dificultad para realizar movimientos con la cadera izquierda. El diagnóstico más probable es:

a. Epifisiólisis de la cabeza femoral
b. Sinovitis transitoria
c. Necrosis avascular de la cabeza femoral
d. Enfermedad de Perthes
e. Artritis séptica

Respuesta correcta: a. Epifisiólisis de la cabeza femoral

Explicación: Es una epifisiólisis de la cabeza femoral clásica: dolor en la cadera (duele en la ingle o en el muslo, incluso en la rodilla) y claudicación de la marcha, en un niño de 12 a 15 años (suele tener antecedente de obesidad). Se diagnostica con radiografías de cadera y se maneja con cirugía. - La sinovitis transitoria es similar, pero suele afectar a niños de 2 a 5 años y tener antecedente de una infección respiratoria previa. Además, es autolimitada, mejorando a los pocos días. - La necrosis avascular de la cabeza femoral y la enfermedad de Perthes son muy similares, solo que la primera afecta a adultos (y se asocia a uso de corticoides, alcoholismo y otros factores de riesgo) y la enfermedad de Perthes afecta a niños entre 5 y 10 años (rango 3 a 12 años y mucho más frecuente en varones), por lo general. - La artritis

séptica suele cursar con fiebre y con signos inflamatorios (eritema, derrama, dolor a la movilización pasiva, etc.).

Fuente: Traumatología y ortopedia, cuestionario 7.2, P4

70. El síndome de Osgood Schlatter se manifiesta clínicamente como:

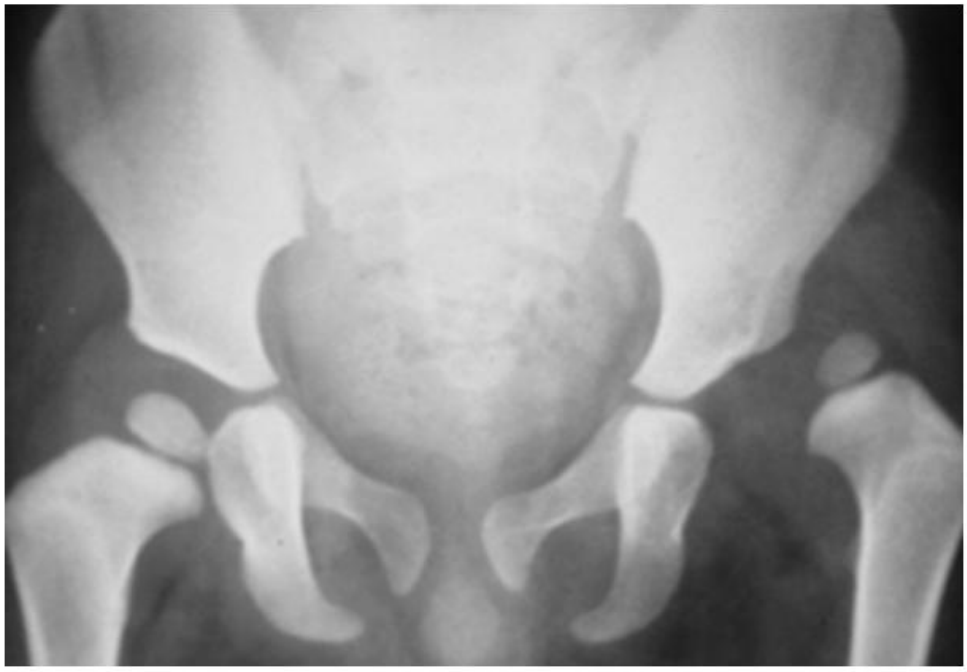
a. Dolor a la palpación de la pata de ganso
b. Dolor a la palpación de la inserción proximal de la fascia lata
c. Dolor a la palpación de la inserción distal de la fascia lata
d. Dolor a la palpación de la tuberosidad tibial
e. Dolor a la palpación de la fosa poplítea

Respuesta correcta: d. Dolor a la palpación de la tuberosidad tibial

Explicación: La enfermedad de Osgood Schlatter es una entesitis del tendón rotuliano, el que se inserta en la tuberosidad tibial. Es clásica de adolescentes. y se produce por movimientos repetitivos (ej. deporte), que provocan una avulsión del núcleo de osificación de la tuberosidad tibial. Suele ser autolimitada y se trata con reposo relativo, AINEs, frío local y educación. - La tendinitis de la pata de ganso (o tendinitis ansarina o bursitis ansarina) duele en la zona medial del extremo proximal de la tibia. Se asocia a artrosis de rodilla y suele ser más intensa cuando se realizan actividades de trekking o trote. - Eso sí, el típico dolor de rodilla al bajar en actividades de trekking a cerros y lugares con mucha pendiente, suele ser la disfunción patelo femoral, que duele especialmente en la cara anterior de la rodilla, por detrás de la rótula. - La tendinitis de la fascia lata (o síndrome de la banda ileotibial) duele en la zona lateral de la rodilla y se asocia a trotar. - Los quistes de Baker o quistes poplíteos podrían doler en la fosa poplítea y tener aumento de volumen en dicha zona. Si se rompen, pueden ser iguales a una TVP.

Fuente: Traumatología y ortopedia, cuestionario 7.2, P7

71. Una niña de 3 meses de edad, nacida por cesárea por podálica, se realiza una radiografía AP de pelvis, la que se muestra en la siguiente imagen (fuente: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:R%C3%B6-schwere_HD-re.jpg): La conducta más adecuada es:



a. Observar evolución
b. Indicar correas de Pavlik
c. Indicar uso de doble pañal
d. Indicar yeso pelvipedio
e. Resolver quirúrgicamente

Respuesta correcta: b. Indicar correas de Pavlik

Explicación: Tiene una luxación congénita de la cadera izquierda o displasia de cadera. - Diagnóstico: El examen con mejor rendimiento para su diagnóstico en los primeros 3-4 meses de edad es la ecografía, por lo que se solicita de elección ante la sospecha clínica precoz (ej. recién nacidos), como por ejemplo en pruebas de Ortolani y/o Barllow alteradas o cuando hay factores de riesgo muy marcados. La radiografía de pelvis, con visualización de ambas caderas tiene un rendimiento aceptable después de los 3 meses: los puntos de corte para el ángulo acetabular a los 3 meses es 30º. Bajo eso es normal. Sobre eso, se considera signo de displasia de cadera. La recomendación chilena plantea: 1. radiografía a los 3 meses como screening y 2. ecografía si sospecha clínica antes. En otros países, se prefiere siempre la ecografía en menores de 4-6 meses. - Tratamiento: En la mayoría de los casos es ortopédico con correas de Pavlik. En los casos en que no responde o el diagnóstico es muy tardío (más de 10 meses), se debe evaluar la utilización de yesos y cirugía (hay casos en que se usan igual las correas de Pavlick después de los 10 meses).

Fuente: Traumatología y ortopedia, cuestionario 7.2, P18 · Traumatología y ortopedia, cuestionario 7.3, P17

72. Un niño de 4 años presenta pie plano bilateral. No es posible formar el arco plantar, aun al hiperextender el primer ortejo. La conducta más adecuada es:

a. Derivar a traumatología
b. Solicitar resonancia magnética nuclear de pie
c. Indicar uso de plantillas
d. Observar evolución
e. Indicar uso de zapatillas blandas

Respuesta correcta: a. Derivar a traumatología

Explicación: Tiene un pie plano, de tipo rígido (porque nunca se forma el arco), por tanto, se debe derivar para evaluación por especialista. Si hubiese sido flexible (se forma el arco al hiperextender el primer ortejo o todos los ortejos, por ejemplo), se podría observar, indicando plantillas, solo en caso de dolor plantar, al caminar. En general, las indicaciones de derivación al especialista en casos de alteraciones del arco plantar son: 1. pie plano rígido, 2. pie plano flexible doloroso y 3. pie cavo.

Fuente: Traumatología y ortopedia, cuestionario 7.2, P20

73. Un niño de 2 años presenta claudicación de la marcha, de 2 días de evolución. Al examen físico está de buen aspecto, afebril, con signos vitales normales. Se aprecia molestia al movilizar la cadera derecha. El diagnóstico más probable es:

a. Enfermedad de Perthes
b. Artritis séptica
c. Epifisiolisis de la cabeza femoral
d. Displasia de cadera
e. Sinovitis transitoria

Respuesta correcta: e. Sinovitis transitoria

Explicación: Es una sinovitis transitoria clásica: niño de 2 a 5 años, con dolor en la cadera o en la rodilla, sin aspecto séptico. Suele ser autolimitada, durando 1 a 2 semanas. - La enfermedad de Perthes suele afectar a niños mayores, entre 5 y 10 años. Algo importante es que estudios más recientes muestran que hay mucha superposición entre las edades de la sinovitis transitorias y la enfermedad de Legg Calvé Perthes (llamada actualmente osteonecrosis idiopática de la cabeza femoral), ya que ambas se presentan con cierta frecuencia entre los 3 y los 8 años (Perthes puede ser en mayores), por tanto, la principal diferencia entre ambas es el tiempo de evolución, ya que la sinovitis suele duran cerca de una semana (solo en pocos casos se alarga y se estudia), mientras que la enfermedad de Perthes suele ser más subaguda. Se diagnostica con la radiografía de caderas, aunque al inicio puede estar normal y ser necesaria una RMN. Se maneja ortopédicamente y, en casos graves, con cirugía. - La epifisiolisis también, entre 12 y 15 años y su clínica se alarga en el tiempo. - La displasia de cadera es un cuadro crónico, con dolor insidioso, que evoluciona a atrosis de cadera y que puede tener cojera, acortamiento de una extremidad, etc. - La artritis séptica tiene fiebre y aspecto séptico, más signos inflamatorios evidentes en la exploración clínica.

Fuente: Traumatología y ortopedia, cuestionario 7.3, P6

74. Un niño de 7 años presenta dolor inguinal desde hace un par de semanas, que ha ido aumentado, hasta producir cojera. Al examen se produce dolor al realizar movimientos de la cadera izquierda. El diagnóstico más probable y la conducta más adecuada son respectivamente:

a. Epifisiolisis de la cabeza femoral y solicitar radiografía de cadera
b. Enfermedad de Perthes y solicitar radiografía de cadera
c. Sinovitis transitoria y observar evolución
d. Artritis séptica y realizar punción articular
e. Sarcoma de Ewing y solicitar radiografía de pelvis

Respuesta correcta: b. Enfermedad de Perthes y solicitar radiografía de cadera

Explicación: Es un niño que claudica, lo que puede ser causado por muchas patologías. De hecho, para diferenciarlas, el examen de primera línea es la radiografía. Por la edad, entre 5 y 10 años y, en especial por lo prolongado de los síntomas, lo primero a pensar es una enfermedad de Perthes. - La epifisiolisis suele ocurrir entre los 12 y 15 años. - La sinovitis, entre los 2 y 5 años y sus síntomas suelen durar solo una semana. - La artritis séptica tiene fiebre y signos inflamatorios. - El sarcoma de Ewing suele afectar a los adolescentes y niños y suele ubicarse en las diáfisis óseas, aunque también puede estar en la pelvis y en cualquier lugar (incluso partes blandas) a cualquier edad, en realidad. Sin embargo, es mucho más raro.

Fuente: Traumatología y ortopedia, cuestionario 7.4, P14

75. Un niño de 4 años presenta pie plano bilateral. Se aprecia que el arco plantar aparece al levantar el pie, pero que desaparece al pisar. La conducta más adecuada es:

a. Observar evolución
b. Indicar plantillas
c. Solicitar radiografía de pie
d. Solicitar resonancia magnética nuclear de pie
e. Derivar a traumatología infantil

Respuesta correcta: a. Observar evolución

Explicación: Es un pie plano flexible (se forma el arco plantar). Se considera algo normal, por lo que se debe observar. Si tuviese dolor, se pueden indicar las plantillas de descarga. Si fuera rígido (no se forma el

arco, ni siquiera con las maniobras de extensión de los ortejos) o tuviese dolos, se debe derivar. El pie cavo se debe derivar (ej. puede ser un pie bot residual).

Fuente: Traumatología y ortopedia, cuestionario 7.4, P15 · Traumatología y ortopedia, cuestionario 7.5, P19

76. Un lactante de 4 meses de edad no ha realizado adecuadamente sus controles pediátricos. Su examen físico es completamente normal. ¿Qué examen recomendaría que se realizara para detectar la presencia de displasia de cadera?

a. Ninguno
b. Radiografía AP de pelvis
c. Radiografías AP y axial de cadera izquierda y cadera derecha
d. Ecografía de caderas
e. Resonancia magnética de caderas

Respuesta correcta: b. Radiografía AP de pelvis

Explicación: El examen de elección para el screening de displasia de cadera es la ecografía de caderas al mes de vida (es el mejor examen entre el nacimiento y los 4 meses). Sin embargo, desde los 3 - 4 meses la radiografía AP de pelvis pasa a ser el examen de elección, en especial en Chile, en que la normativa obliga a hacer una radiografía de pelvis a los 3 meses, como screening a todo niño. El diagnóstico precoz es fundamental, ya que permite un tratamiento sencillo con correas de Pavlik. En cambio, después de los 10 meses se debe evaluar la cirugía o la inmovilización con yesos.

Fuente: Traumatología y ortopedia, cuestionario 7.4, P16

77. Un niño de 13 años presenta cojera desde hace 2 semanas, que ha ido en aumento. Además, presenta dolor en la ingle y el muslo derecho. Al examen físico se aprecia en buenas condiciones generales y presenta dolor con los movimientos de la cadera derecha. El resto del examen físico es normal. El diagnóstico más probable es:

a. Epifisiolisis de la cabeza femoral
b. Sinovitis transitoria
c. Enfermedad de Perthes
d. Necrosis avascular de la cabeza femoral
e. Síndrome de Osgood Schlatter

Respuesta correcta: a. Epifisiolisis de la cabeza femoral

Explicación: Salvo la enfermedad de Osgood Schlatter, que produce dolor en la rodilla (en la inseción del tendón rotuliano), todas las opciones producen dolor en la cadera, por lo que la diferencia la hace la edad. - La epifisiolisis de la cabeza femoral suele afectar a niños entre 12 y 15 años, de preferencia obesos. - La sinovitis transitoria suele mejorar en una semana y afecta a niños entre 2 y 5 años, aunque puede ser en mayores. - La enfermedad de Perthes afecta a niños entre 5 y 10 años (rango puede ser más amplio: 3 a 12 años) y sus síntomas son insidiosos y persistentes. - La necrosis avascular de la cabeza femoral afecta a adultos, en especial, a usuarios de corticoides y a alcohólicos.

Fuente: Traumatología y ortopedia, cuestionario 7.5, P1

Tumores óseos (5)

78. Un niño de 12 años presenta aumento de volumen, en relación a la pierna izquierda, que notó hace tres meses y que se asocia a dolor. Al examen físico se aprecia de consistencia dura, por lo que se solicita una radiografía, que visualiza una lesión de 15 cm de diámetro en la diáfisis de la tibia, con regiones

radiolúcidas y otras de mayor densidad que el hueso, que lo deforma y borra el hueso cortical en algunas zonas. El diagnóstico más probable es:

a. Osteomielitis crónica
b. Osteosarcoma
c. Osteoma osteoide
d. Osteocondroma
e. Sarcoma de Ewing

Respuesta correcta: e. Sarcoma de Ewing

Explicación: Es un tumor óseo de aspecto maligno: borra la cortical, es heterogéneo y deforma el hueso. Además, por ser un niño y estar en localización diafisiaria, es un sarcoma de Ewing clásico. La osteomielitis tiene fiebre y lesiones líticas. El osteosarcoma tiene ubicación metafisiaria o diafisiaria. El osteoma osteoide y el osteocondroma tienen aspecto benigno.

Fuente: Traumatología y ortopedia, cuestionario 7.1, P7

79. Un paciente de 68 años presenta dolor en el brazo izquierdo. Al examen físico se aprecia aumento de volumen de consistencia ósea, por lo que se solicita una radiografía de húmero que muestra un tumor óseo de 7 cm de diámetro, de consistencia heterogénea y reacción perióstica “en tela de cebolla”. El diagnóstico más probable es:

a. Sarcoma de Ewing
b. Tumor de células gigantes
c. Osteocondroma
d. Osteosarcoma
e. Osteoma osteoide

Respuesta correcta: d. Osteosarcoma

Explicación: Tiene aspecto maligno: lesión heterogénea, con reacción perióstica compleja (en tela de cebolla o en sol naciente son las dos reacciones sugerentes de cáncer). Por la edad y la localización metafisiaria/epifisiaria, lo más probable es que sea un osteosarcoma (adultos mayores y adolescentes). La edad de presentación de los osteosarcomas es bimodal: 13-16 años y luego adultos mayores. - El sarcoma de Ewing también tiene aspecto maligno, pero afecta a adolescentes y niños y se localiza más frecuentemente en las diáfisis de huesos largos o en la pelvis. - El tumor de células gigantes también tiene aspecto maligno o lítico, pero afecta principalmente a hombres de 40 a 50 años y se localiza en la tibia proximal o el fémur distal. - El osteocondroma y el osteoma osteoide son de aspecto benigno.

Fuente: Traumatología y ortopedia, cuestionario 7.2, P6

80. Un paciente de 20 años consulta por aumento de volumen, en relación a la zona proximal de la tibia. Al examen se palpa de consistencia ósea, por lo que se solicita una radiografía de rodilla, que muestra un tumor óseo pediculado, de aspecto similar al hueso, que se origina en la metáfisis de la tibia. Está bien delimitado, que no afecta las partes blandas. El diagnóstico más probable es:

a. Sarcoma de Ewing
b. Tumor de células gigantes
c. Osteocondroma
d. Osteoma osteoide
e. Osteosarcoma

Respuesta correcta: c. Osteocondroma

Explicación: Es un osteocondroma clásico: aspecto benigno (biel delimitado, que respeta partes blandas) y pediculado. El sarcoma de Ewing, tumor de células gigantes y osteosarcoma tienen aspecto maligno. El osteoma osteoide sí tiene aspecto benigno, pero es una lesión redondeada, radiolúcida, con un halo radiopaco, ubicado en zona cortical.

Fuente: Traumatología y ortopedia, cuestionario 7.3, P2

81. Un niño de 12 años presenta aumento de volumen y dolor en la pierna derecha. Al examen físico se aprecia aumento de volumen, en relación a la diáfisis de la tibia. Se solicita una radiografía de pierna que muestra un tumor óseo de 7 cm de diámetro mayor, con áreas líticas y compromiso del hueso cortical, de aspecto heterogéneo y con reacción perióstica en "tela de cebolla". El diagnóstico más probable es:

a. Metástasis
b. Sarcoma de Ewing
c. Osteomielitis crónica
d. Osteoma osteoide
e. Osteocondroma

Respuesta correcta: b. Sarcoma de Ewing

Explicación: Tiene aspecto maligno (heterogéneo, disrupción de la cortical, reacción perióstica compleja). Además, por ser un niño y estar localizado en la diáfisis, lo más probable es que sea un sarcoma de Ewing. - Las metástasis suelen ser múltiples y tener sintomatología del cáncer de base. - La osteomielitis es una lesión lítica y tiene fiebre y dolor, aunque puede ser indistinguible de un sarcoma de Ewing, sin una resonancia magnética. - El osteoma osteoide y el osteocondroma son benignos y por tanto tienen aspecto benigno. - El esteosarcoma (no está en las opciones) puede ser muy similar, pero suele ubicarse en metáfisis o epífisis (a diferencia del Sarcoma de Ewing que afecta las diáfisis) y se da en adultos mayores, aunque también en adolescentes entre 13 y 16 años.

Fuente: Traumatología y ortopedia, cuestionario 7.4, P2

82. Un paciente de 34 años consulta por dolor en relación en el muslo derecho, en especial en la noche, que cede con AINEs. Se solicita una radiografía, que muestra una lesión ósea en el cuello femoral de 1 cm de diámetro, en relación al hueso cortical. Respeta a este último y está bien delimitado, con una zona redondeada radiolúcida en su interior y rodeadea de un halo de hueso más radiopaco. El diagnóstico más probable es:

a. Quiste óseo simple
b. Osteosarcoma
c. Osteoma osteoide
d. Osteocondroma
e. Tumor de células gigantes

Respuesta correcta: c. Osteoma osteoide

Explicación: Es un osteoma osteoide clásico: aspecto benigno, radiolúcido, con halo radiopaco, en ubicación cortical. Además, es característico que duela más en la noche y que disminuya el dolor con los AINEs. Suele afectar mayormente a hombres jóvenes. El quiste óseo simple se ve como una lesión radiolúcida, pero sin halo radiopaco y generalmente sin dolor. El osteocondroma tiene una forma polipoidea y generalmente no tiene síntomas. El tumor de células gigantes es localmente agresivo y produce dolor, sin embargo, se ve de aspecto radiolúcido o heterogéneo y suele afectar a hombres de edad media (40 - 50 años).

Fuente: Traumatología y ortopedia, cuestionario 7.5, P7

Infecciones osteoarticulares (6)

83. El tratamiento de primera línea de la osteomielitis aguda, en la que no se sospecha resistencia, es:

a. Cloxacilina endovenosa
b. Cefadroxilo oral
c. Vancomicina endovenosa
d. Gentamicina local
e. Quirúrgico

Respuesta correcta: a. Cloxacilina endovenosa

Explicación: El manejo de la osteomielitis es distinto, según se trate de una osteomielitis hematógena (como en este caso, que no tiene una causa aparente) o se trate de una osteomielitis por contigüidad (ej. fractura expuesta, pie diabético). - La hematógena se trata con antibióticos endovenosos, ajustados por antibiograma y, si queda tejido infectado residual, se realiza debridamiento quirúrgico. - La por contigüidad se trata con debridamiento quirúrgico (amputación en los casos más graves), más antibióticos, ajustados por antibiograma. * Aunque el S. aureus sensible es el agente más frecuente, actualmente, mientras no se haya aislado el agente, se recomienda dejar cobertura para gram positivos, con cobertura para SAMR y para gram negativos. Ejemplo: Vancomicina + cefepime. Una vez se tiene el antibiograma, se ajusta el tratamiento. Eso sí, algunas guías mantienen el tratamiento estándar con cloxacilina o vancomicina, con cobertura solo para el SAMS y aquello ocurre especialmente cuando no se sospecha resistencia, como en este caso.

Fuente: Traumatología y ortopedia, cuestionario 7.1, P6

84. Un paciente de 20 años presenta fiebre, asociado a dolor de la rodilla derecha. Al examen se aprecia aumento de volumen, eritema y signos de derrame articular. Se realiza punción, con salida de líquido sinovial turbio, con más de 100.000 leucocitos por mm3 y presencia de cocáceas Gram positivas. La conducta más adecuada es:

a. Administrar ceftriaxona endovenosa y realizar aseo quirúrgico
b. Administrar vancomicina endovenosa
c. Administrar cloxacilina más vancomicina endovenosa y realizar aseo quirúrgico
d. Administrar cefazolina endovenosa
e. Administrar vancomicina + metronidazol endovenoso

Respuesta correcta: c. Administrar cloxacilina más vancomicina endovenosa y realizar aseo quirúrgico

Explicación: Tiene una artritis séptica, por Staphilococcus aureus (Gram positivo). Se trata con drenaje quirúrgico, más antibióticos endovenosos. En este caso, sirve la cloxacilina y la cefazolina, ya que cubren bien al estafilococo, sin embargo, debido al aumento de la resistencia, muchas guías recomiendan agregar vancomicina. Así el esquema primario, puede ser cloxacilina o cefazolina más vancomicina, aunque algunos dejarán solo uno de esos antibióticos. - Si hubiese sido por gonococo / Neisseria meningitidis (Gram negativo), la respuesta habría sido ceftriaxona más drenaje quirúrgico.

Fuente: Traumatología y ortopedia, cuestionario 7.2, P3

85. Un paciente de 20 años presenta aparición de una zona eritematosa en la pierna derecha de 5 cm, asociada a fiebre e intenso dolor. Un día después alcanza 15 cm de diámetro y presenta algunas áreas violáceas y otras negras. La conducta más adecuada es:

a. Solicitar resonancia magnética nuclear y decidir conducta según resultado.

b. Administrar penicilina + clindamicina endovenosa y realizar debridamiento quirúrgico
c. Administrar cloxacilina + gentamicina endovenosa
d. Administrar ceftriaxona + metronidazol y realizar debridamiento quirúrgico
e. Administrar cloxacilina endovenosa y realizar debridamiento quirúrgico

Respuesta correcta: b. Administrar penicilina + clindamicina endovenosa y realizar debridamiento quirúrgico

Explicación: Tiene una fasceítis necrotizante clásica. Se trata con debridación quirúrgica urgente, más tratamiento antibiótico endovenoso. Generalmente se usa penicilina (algunos agregan clindamicina), ya que suele ser por Streptococcus pyogenes. Si se sobreinfectara con S. aureus, se agrega cloxacilina, pero el agente es el S. pyogenes. La tipo 1 (polimicrobiana) se asocia a pie diabético, escaras y otras patologías de base. Se trata con debridación quirúrgica y antibióticos de amplio espectro que cubran todo.

Fuente: Traumatología y ortopedia, cuestionario 7.3, P1

86. El tratamiento antibiótico empírico de elección en la osteomielitis aguda hematógena, mientras no se cuente con un estudio de sensibilidad, en la actualidad, es:

a. Vancomicina más cefepime
b. Penicilina
c. Cloxacilina
d. Ceftriaxona + metronidazol
e. Cefazolina + metronidazol

Respuesta correcta: a. Vancomicina más cefepime

Explicación: El manejo de la osteomielitis es distinto, según se trate de una osteomielitis hematógena (como en este caso, que no tiene una causa aparente) o se trate de una osteomielitis por contigüidad (ej. fractura expuesta, pie diabético). - La hematógena se trata con antibióticos endovenosos, ajustados por antibiograma y, si queda tejido infectado residual, se realiza debridamiento quirúrgico. - La por contigüidad se trata con debridamiento quirúrgico (amputación en los casos más graves), más antibióticos, ajustados por antibiograma. * Aunque el S. aureus sensible es el agente más frecuente, actualmente, mientras no se haya aislado el agente, se recomienda dejar cobertura para gram positivos, con cobertura para SAMR y para gram negativos. Ejemplo: Vancomicina + cefepime. Una vez se tiene el antibiograma, se ajusta el tratamiento.

Fuente: Traumatología y ortopedia, cuestionario 7.3, P11

87. Un paciente de 30 años, con antecedente de promiscuidad sexual consulta por dolor en relación al codo derecho y a la rodilla izquierda. Al examen físico se aprecia febril (t°: 38,8°C), con eritema dolor y signos de derrame articular de las articulaciones descritas. Se realiza punción articular, que demuestra un líquido inflamatorio, con presencia de cocáceas Gram negativas intracelulares. La conducta más adecuada es:

a. Indicar ciprofloxacino oral
b. Indicar cloxacilina oral
c. Indicar ceftriaxona endovenosa y realizar drenaje articular quirúrgico
d. Indicar cloxacilina endovenosa y realizar drenaje articular quirúrgico
e. Indicar ceftriaxona endovenosa

Respuesta correcta: c. Indicar ceftriaxona endovenosa y realizar drenaje articular quirúrgico

Explicación: Tiene una artritis séptica por Neisseria gonorrhoeae (gonococo). Se trata con ceftriaxona endovenosa, más drenaje quirúrgico de la articulación. Vale la pena recordar que la uretritis por gonorrea se trata con ceftriaxona intramuscular, en una dosis.

Fuente: Traumatología y ortopedia, cuestionario 7.4, P3

88. Actualmente, el tratamiento de primera línea de la artritis séptica es:

a. Vancomicina endovenosa más drenaje quirúrgico
b. Drenaje quirúrgico solo
c. Ceftriaxona endovenosa más drenaje quirúrgico
d. Gentamicina local
e. Cefazolina más gentamicina más metronidazol por vía endovenosa

Respuesta correcta: a. Vancomicina endovenosa más drenaje quirúrgico

Explicación: El tratamiento de la artritis séptica (AS) consiste en antibióticos endovenosos, ajustados por antibiograma, más drenaje quirúrgico, idealmente por vía artroscópica. Generalmente son por S. aureus, por lo que, al no dar más información la pregunta, se asume que se trata de una artritis séptica de las más frecuentes. Cuando son por Staphilococcus aureus (lo más frecuente), si bien el tratamiento inicial históricamente ha sido la cloxacilina u otro betalactámico con acción antiestafilocócica, dado el aumento de la prevalencia de estafilococos resistentes, actualmente se prefiere iniciar con vancomicina y cambiar el antibiótico, una vez que se tenga el estudio de susceptibilidad. Si en el Gram se ven cocáceas Gram negativas, se asume que es por gonococo y el antibiótico es ceftriaxona. Si en el Gram se ven bacilos Gram negativos, se debe cubrir pseudomona, con dos antibióticos idealmente.

Fuente: Traumatología y ortopedia, cuestionario 7.5, P6

Patología de columna (6)

89. Un paciente presenta dolor lumbar irradiado a la extremidad derecha, que inició luego de realizar esfuerzo físico. El dolor avanza por la cara anteromedial del muslo y desciende por la cara medial de la pierna. Además, se aprecia clara disminución del reflejo rotuliano de dicha extremidad. La raíz nerviosa afectada es:

a. L1
b. L2
c. L4
d. L5
e. S1

Respuesta correcta: c. L4

Explicación: L1 inerva la zona inguinal. L2 inerva la cara anterior y medial del muslo y algo afecta el reflejo rotuliano. L4 inerva la zona lateral y anterior del muslo y luego la cara medial de la pierna, hasta el maléolo medial. Junto con L2 y L3, inervan el cuádriceps (extienden la rodilla) y afectan el reflejo rotuliano. Además, dorsiflecta el pie. L5 inerva la cara posterior del muslo y luego la cara anterior de la pierna, el empeine. No afecta ningún reflejo. Extiende los ortejos, en especial, el primero. S1 afecta la cara posterior del muslo y pierna, más la planta del pie y la zona lateral del pie. Afecta el reflejo aquileano.

Fuente: Traumatología y ortopedia, cuestionario 7.1, P9 · Traumatología y ortopedia, cuestionario 7.5, P9

90. ¿Qué patología hay que sospechar ante un paciente que presenta lumbago intenso luego de una caída de altura, de pie?

a. Espondilodiscitis
b. Espondilosis
c. Espondilolistesis
d. Herniación del núcleo pulposo
e. Fractura de cuerpo vertebral

Respuesta correcta: e. Fractura de cuerpo vertebral

Explicación: Las caídas de altura, cayendo de pie, se asocian a 3 fracturas: vértebras (aplastamiento del cuerpo vertebral), talones y platillos tibiales. La espondilodiscitis es un lumbago o lumbociática, a la que se le agrega fiebre. La espondilosis es lo mismo que la artrosis de la columna. La espondilolistesis es el desplazamiento de uno de los cuerpos vertebrales. La hernia de núcleo pulposo (HNP) produce una lumbociática común y corriente.

Fuente: Traumatología y ortopedia, cuestionario 7.2, P12

91. Un paciente de 56 años, con sobrepeso, consulta por dolor lumbar muy intenso, que inició hace 24 horas, luego de haber levantado un bolso pesado. El dolor se irradia por la cara posterior de la pierna izquierda, hasta alcanzar el talón. Al examen físico no hay alteraciones en la sensibilidad ni en la movilidad distal, sin embargo, se reproduce el dolor al realizar la maniobra de Lasegue. La conducta más adecuada es:

a. Solicitar resonancia magnética nuclear
b. Solicitar electromiografía
c. Solicitar radiografía de columna lumbosacra
d. Resolver quirúrgicamente de inmediato
e. Indicar analgésicos, reposo relativo y controlar de manera ambulatoria

Respuesta correcta: e. Indicar analgésicos, reposo relativo y controlar de manera ambulatoria

Explicación: Tiene una lumbociática clásica, sin signos de alarma. La simple irradiación del dolor no es un signo de alarma. Se debe tratar igual que el lumbago mecánico, con analgesia, reposo relativo y en una segunda instancia, con ejercicios de fortalecimiento de la musculatura lumbar. La resonancia solo se pide si es que hubiese signos de alarma (ej. Déficit neurológico, dolor mayor a 2 semanas que va en aumento o se mantiene muy intenso, o mayor a 4-6 semanas o, baja de peso, fiebre, etc.). Generalmente no se solicitan imágenes (menos del 1% de los casos la requiere).

Fuente: Traumatología y ortopedia, cuestionario 7.2, P15

92. Un paciente de 40 años consulta por dolor cervical intenso, que inició luego de levantar a su hija. El dolor se irradia a la mano izquierda y le impide realizar movimientos con el cuello. Al examen físico no presenta déficit nervioso. La conducta más adecuada es:

a. Solicitar ecografía cervical e iniciar analgésicos y reposo
b. Solicitar resonancia magnética nuclear e iniciar analgésicos y reposo
c. Indicar analgésicos y reposo relativo
d. Indicar uso de collar cervical por riesgo de lesión medular
e. Solicitar TAC de cuello e iniciar analgésicos y reposo

Respuesta correcta: c. Indicar analgésicos y reposo relativo

Explicación: Tiene una cervicobraquialgia aguda mecánica clásica, sin signos de alarma (la simple irradiación del dolor a la extremidad superior no es signo de alarma). No requiere exámenes y se trata con reposo relativo, AINES y en una segunda instancia, se indica ejercicios de fortalecimiento del dorso y cuello. Si hubiese tenido signos de alarma (déficit neurológico, dolor mayor a 6 semanas, fiebre, antecedente de trauma, etc.) se debería pedir una resonancia magnética nuclear.

Fuente: Traumatología y ortopedia, cuestionario 7.3, P12

93. Un paciente presenta cervicalgia aguda, luego de realizar deporte. El dolor es muy intenso, irradiándose por la cara anterolateral de la extremidad superior derecha, hasta el pulgar. Al examen físico se aprecia limitación de la movilidad cervical, por el dolor. La sensibilidad y la movilidad de la mano y el brazo están conservadas. La conducta más adecuada es:

a. Indicar reposo relativo y AINES y controlar de modo ambulatorio
b. Indicar AINES y reposo y solicitar ecografía cervical
c. Indicar AINES y reposo y solicitar RMN de columna cervical
d. Indicar AINES y reposo y solicitar radiografía de columna cervical
e. Hospitalizar y resolver quirúrgicamente

Respuesta correcta: a. Indicar reposo relativo y AINES y controlar de modo ambulatorio

Explicación: Tiene una cervicobraquialgia aguda mecánica clásica, sin signos de alarma (la simple irradiación del dolor a la extremidad superior no es signo de alarma). No requiere exámenes y se trata con reposo relativo, AINES y en una segunda instancia, se indica ejercicios de fortalecimiento del dorso y cuello. SI hubiese tenido signos de alarma (déficit neurológico [afectación de la sensibilidad, movilidad o reflejos], dolor mayor a 6 semanas, fiebre, antecedente de trauma, etc.) se debería pedir una resonancia magnética nuclear.

Fuente: Traumatología y ortopedia, cuestionario 7.4, P5

94. Un paciente de 56 años consulta por dolor cervical, que inició luego de hacer ejercicios. El dolor inició de manera súbita y es muy intenso, limitando los movimientos del cuello y cediendo con el reposo. No presenta déficit neurológico, ni signos inflamatorios. La conducta más adecuada es:

a. Indicar reposo relativo y analgésicos orales
b. Solicitar una radiografía de cuello
c. Solicitar una resonancia magnética nuclear de cuello
d. Solicitar un TAC de cuello
e. Resolver quirúrgicamente

Respuesta correcta: a. Indicar reposo relativo y analgésicos orales

Explicación: Tiene una cervicobraquialgia aguda mecánica clásica, sin signos de alarma (la simple irradiación del dolor a la extremidad superior no es signo de alarma). No requiere exámenes y se trata con reposo relativo, AINES y en una segunda instancia, se indica ejercicios de fortalecimiento del dorso y cuello. Si hubiese tenido signos de alarma (déficit neurológico, dolor mayor a 6 semanas, fiebre, antecedente de trauma, etc.) se debería pedir una resonancia magnética nuclear.

Fuente: Traumatología y ortopedia, cuestionario 7.5, P13

Obstetricia (60)

Control prenatal y diagnóstico de embarazo (12)

1. Usted recibe a una mujer de 25 años, ya que se realizó un test de embarazo, que resultó positivo. Refiere que su última regla fue hace 8 semanas y que normalmente ocurren cada 6 a 8 semanas. ¿Cuál es la conducta más adecuada para determinar la edad gestacional es esta paciente?

a. Determinar niveles plasmáticos de subunidad beta-HCG
b. Realizar una ecografía transvaginal de inmediato
c. Utilizar como referencia la fecha de la última regla
d. Utilizar como referencia la fecha en que se tomó la prueba de embarazo
e. Realizar una ecografía obstétrica a las 20 semanas de amenorrea

Respuesta correcta: b. Realizar una ecografía transvaginal de inmediato

Explicación: Como sus reglas son irregulares, su FUR no es confiable y no puede ser usada como método de determinación de la edad gestacional. La ecografía será el método de elección y mientras más precoz se realice, más preciso será su resultado.

Fuente: Obstetricia, cuestionario 1.1, P2

2. Una mujer presenta su primer embarazo, confirmado con subunidad beta. Durante los controles del primer trimestre debe realizarse todos los siguientes exámenes, EXCEPTO:

a. Hemograma
b. VDRL y Elisa para VIH
c. Glicemia de ayuno
d. Registro basal no estresante
e. Grupo y Rh materno

Respuesta correcta: d. Registro basal no estresante

Explicación: El RBNE solo sirve en la segunda mitad del embarazo (en general en el tercer trimestre), para ver la vitalidad fetal. Los demás exámenes se piden al inicio del embarazo. También se piden TORCH, serología para Chagas, urocultivo y la ecografía transvaginal.

Fuente: Obstetricia, cuestionario 1.1, P5

3. Una mujer se realiza un test de embarazo, el que resulta positivo. Acude a su primer control obstétrico, donde se realiza una ecografía transvaginal, que no visualiza el saco gestacional. Se solicitan niveles plasmáticos de gonadotrofina coriónica, que resultan 1.000 UI/L. La conducta más adecuada es:

a. Enviar a domicilio, indicando reposo y mantener los controles normales del embarazo
b. Indicar metotrexato
c. Realizar legrado uterino
d. Solicitar nueva ecografía en 10 días
e. Repetir la ecografía y la beta-HCG en 48 horas

Respuesta correcta: e. Repetir la ecografía y la beta-HCG en 48 horas

Explicación: Por tener una ecografía negativa, con test de embarazo positivo, la sospecha diagnóstica es un embarazo ectópico. Se debe estudiar con HCG, que si está mayor a 1.500 a 3.500 UI/L (varía según la fuente) confirma el diagnóstico, pero si está bajo ese rango (como en este caso), se debe controlar en 48

horas con una nueva ecografía y niveles de HCG, ya que también puede tratarse de un embarazo normal menor a 5 semanas, que todavía no se ve en la ecografía.

Fuente: Obstetricia, cuestionario 1.1, P6

4. Usted atiende a una mujer de 46 años, hipertensa, en tratamiento con enalapril e hidroclorotiazida, que consulta debido a que está embarazada, con 5 semanas de amenorrea. ¿Cuál es la conducta más adecuada para el manejo de su hipertensión arterial?

a. Mantener el tratamiento
b. Suspender el tratamiento farmacológico actual e iniciar betabloqueantes
c. Reemplazar el enalapril por losartán y mantener la hidroclorotiazida
d. Mantener el enalapril y reemplazar la hidroclorotiazida por espironolactona
e. Suspender el tratamiento farmacológico actual e iniciar alfametildopa

Respuesta correcta: e. Suspender el tratamiento farmacológico actual e iniciar alfametildopa

Explicación: La HTA crónica, en el embarazo, se debe tratar con alfametildopa (puede agregarse hidralazina), de modo de mantener presiones arteriales bajo 140/90 mmHg (Minsal: bajo 150/100). Los demás antihipertensivos están contraindicados, ya que pueden producir malformaciones y otras complicaciones.

Fuente: Obstetricia, cuestionario 1.1, P7

5. Una mujer con 35 semanas de gestación acude a control, porque ha notado una disminución en los movimientos fetales y está preocupada. La conducta más adecuada es:

a. Realizar un registro basal no estresante de la frecuencia cardíaca fetal
b. Realizar un perfil biofísico
c. Realizar un test de tolerancia a las contracciones
d. Realizar una ecografía doppler umbilical
e. Realizar una ecografía doppler de arterias uterinas

Respuesta correcta: a. Realizar un registro basal no estresante de la frecuencia cardíaca fetal

Explicación: Es una pregunta difícil, ya que las opciones A, B, C y D evalúan el bienestar fetal. Sin embargo, como examen de primera línea ante la disminución de los movimientos fetales, se debe realizar un registro basal no estresante (RBNE). Solo si está no reactivo por 40 minutos, se procede al perfil biofísico (PBF). Sin embargo, vale la pena aclarar que el PBF es una excelente herramienta y también es una respuesta correcta, en estricto rigor. - El TTC solo se puede hacer en mayores de 36 semanas y en general se hace después de haber hecho un RBNE (puede inducir un parto prematuro). - El Doppler umbilical es útil, pero para evaluar patologías más crónicas, como la preclamsia o el RCIU. - Finalmente, el Doppler de uterinas no se utiliza en la evaluación fetal, sino que sirve para el screening de preclamsia, aunque su evidencia sea muy escasa.

Fuente: Obstetricia, cuestionario 1.1, P16

6. Una mujer de 30 años, cursando un embarazo de 35 semanas, consulta por disminución de la percepción de los movimientos fetales. Se realiza un registro basal no estresante que muestra lo siguiente: La conducta más adecuada es:

a. Repetir el registro por 20 minutos adicionales
b. Solicitar perfil biofísico
c. Interrumpir con misoprostol

d. Interrumpir por cesárea

e. Tranquilizar y enviar a domicilio, manteniendo una conducta expectante

Respuesta correcta: e. Tranquilizar y enviar a domicilio, manteniendo una conducta expectante

Explicación: Tiene un RBNE reactivo (2 o más aceleraciones en 20 minutos; en este caso tiene 6). Por tanto, se debe tranquilizar.

Fuente: Obstetricia, cuestionario 1.1, P20

7. Una mujer de 32 años, cursando un embarazo de 28 semanas, se realiza un hemograma, con hematocrito de 30% y hemoglobina de 10 g/dl. La conducta más adecuada es:

a. Observar evolución

b. Iniciar hierro oral

c. Solicitar biopsia de médula ósea

d. Solicitar prueba de Coombs

e. Realizar ecodoppler de arteria cerebral media fetal

Respuesta correcta: b. Iniciar hierro oral

Explicación: La anemia en el embarazo se diagnostica con una hemoglobina bajo 11 g/dl o bajo 10,5 g/dl, si está en el segundo semestre. Por tanto, tiene anemia. A menos que el hemograma muestre algo especial (lo que no se describe en el caso, por lo que hay que suponer que no lo hace), toda anemia en el embarazo se trata como si fuera ferropénica. Actualmente, se recomienda solicitar igualmente una ferrita o perfil de hierro en las embarazadas con anemia. Si no responde o si el hemograma o perfil de fierro sugieren otra causa, sí se debe estudiar con otros exámenes y, eventualmente, suspender el hierro.

Fuente: Obstetricia, cuestionario 1.2, P7

8. Una mujer de 34 años VIH positivo en tratamiento antirretroviral, consulta por atraso menstrual. Se realiza un test de embarazo, que resulta positivo. Actualmente está asintomática y su nivel de linfocitos CD4 es de 1.080 por mm3 y su carga viral es indetectable. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

a. Mantener el tratamiento antirretroviral

b. Suspender el tratamiento antirretroviral durante todo el embarazo

c. Remplazar el tratamiento por monoterapia con efavirenz

d. Reemplazar el tratamiento por monoterapia con zidovudina

e. Suspender el tratamiento hasta la semana 24 y luego reiniciarlo, asegurándose que no reciba efavirenz

Respuesta correcta: a. Mantener el tratamiento antirretroviral

Explicación: Si está en TAR y la carga viral está indetectable, es mejor mantenerla. Actualmente el tratamiento del VIH en el embarazo se puede resumir en los siguiente: 1. Todos los pacientes con VIH deberían tener terapia combinada, ya que sus potenciales riesgos son menores a los beneficios. El embarazo no es la excepción. Por tanto, es mejor tratar que no hacerlo y es mejor hacerlo con dos o tres fármacos que solo con uno. 2. La mayoría de los antivirales han demostrado ser seguros en el embarazo. Incluso el efavirenz, que inicialmente se creyó teratogénico, actualmente cuenta con evidencia de ser seguro. 3. Al parto se debe manejar con cesárea si la carga viral está positiva (>1.000 copias aparece como rango en muchos textos). 4. Además se da una carga de zidovudina en el parto. 5. El recién nacido tiene contraindicación de la leche materna y debe recibir triterapia, controlándose con PCR (Elisa y western blot no sirven, ya que resultan falsamente positivos, por los anticuerpos maternos).

Fuente: Obstetricia, cuestionario 1.2, P11

9. Una mujer cursa un embarazo de 38+4 semanas, con buen control prenatal, sin complicaciones. Se realiza una fetometría, que muestra un feto de 4.000 g. Su test de tolerancia a la glucosa oral es normal. La conducta más adecuada es:

a. Observar evolución
b. Inducir el parto con misoprostol
c. Realizar cesárea
d. Iniciar dieta y ejercicio
e. Iniciar insulina

Respuesta correcta: a. Observar evolución

Explicación: Es un embarazo de término, con un bebé grande para la edad gestacional. Sin embargo, no cumple con criterios de macrosomía fetal (no es mayor a 4.500g), por lo que no requiere interrupción. Si pasa de los 4.500, sí se deberá proceder a hacer una cesárea. En el caso de la diabetes gestacional y pregestacional, que tienen mayor riesgo de retención de hombros, no hay consenso sobre el punto de corte de peso sobre el cual se debe hacer cesárea: - La evidencia sugiere el mismo corte de 4.500 gramos para la DMG y entre 4.000 y 4.500 gramos, según la fuente, para la pregestacional (DMPG). El Minsal ha recogido el corte de 4.500 gramos en sus actualizaciones.

Fuente: Obstetricia, cuestionario 1.2, P14

10. Una mujer de 20 años, cursando un embarazo de 40 semanas de edad gestacional, se realiza un registro basal no estresante, por 20 minutos, que muestra el siguiente trazado: La conducta más adecuada es:

a. Interrumpir el embarazo
b. Observar evolución
c. Solicitar un perfil biofísico
d. Solicitar un test de tolerancia a las contracciones
e. Alargar el registro basal no estresante por 20 minutos más

Respuesta correcta: e. Alargar el registro basal no estresante por 20 minutos más

Explicación: El RBNE está no reactivo (no tiene aceleraciones y para ser reactivo requiere al menos 2 en los 20 minutos). Por tanto, se debe alargar por 20 minutos más. Si cambia a reactivo, se observa evolución y se da alta. Si se mantiene no reactivo, se debe pedir un PBF o un TTC (porque tiene más de 36 semanas).

Fuente: Obstetricia, cuestionario 1.2, P19

11. Una mujer de 28 años presenta atraso menstrual, por lo que se realiza un test de embarazo, que resulta positivo. Acude a control, realizándose una ecografía transvaginal, que muestra ausencia de gestación intrauterina. Se solicita beta-HCG que resulta 400 UI/L. Se repite la ecografía 48 horas después, sin poder visualizar una gestación intrauterina y se repite también la beta-HCG, resultando 800 UI/L. El diagnóstico más probable es:

a. Embarazo ectópico
b. Embarazo normal
c. Aborto retenido
d. Aborto completo
e. Embarazo molar

Respuesta correcta: b. Embarazo normal

Explicación: Por tener una HCG menor a 1.500-3.500 UI/L (según la fuente varía), puede ser un embarazo normal, de menor edad gestacional o un embarazo ectópico. Por ello, se debe repetir la HCG en 48 horas. Si aumenta más de un 66%, probablemente es un embarazo normal (como en este caso) y se segurá con HCG y ecografía. Si aumenta menos de 66%, probablemente es un embarazo ectópico.

Fuente: Ginecología, cuestionario 2.1, P5

12. Una mujer de 28 años presenta atraso menstrual, por lo que se realiza un test de embarazo, que resulta positivo. Acude a control, realizándose una ecografía transvaginal, que muestra ausencia de gestación intrauterina. Se solicita beta-HCG que resulta 400 UI/L. La conducta más adecuada es:

a. Realizar legrado
b. Repetir la beta-HCG en 48 horas
c. Repetir la ecografía en 7 días
d. Observar evolución, sin necesidad de controles en el corto plazo
e. Iniciar metotrexato

Respuesta correcta: b. Repetir la beta-HCG en 48 horas

Explicación: Tiene una sospecha de embarazo ectópico. Sin embargo, por tener una HCG menor a 1.500-3.500 UI/L (varía según la fuente), también puede ser un embarazo normal, de menor edad gestacional. Por ello, se debe repetir la HCG en 48 horas. Si aumenta más de un 66%, probablemente es un embarazo normal y se segurá con HCG y ecografía. Si aumenta menos de 66%, probablemente es un embarazo ectópico.

Fuente: Ginecología, cuestionario 2.2, P5

Metrorragia del primer trimestre, embarazo ectópico y molar (6)

13. Una mujer cursando un embarazo de 8 semanas de edad gestacional, inicia metrorragia escasa, sin otros síntomas, que en la especuloscopía se aprecia proveniente del OCE. La subunidad beta resulta 2.000 UI/L y la ecografía transvaginal muestra un cuello cerrado, de 4 cm de largo, con un saco gestacional intrauterino, de 40 mm de diámetro, con presencia de un embrión de 12 mm de diámetro con latidos cardiofetales presentes. La conducta más adecuada es:

a. Solicitar nueva beta-HCG y nueva ecografía en 48 horas
b. Solicitar nueva ecografía en 10 días por sospecha de aborto retenido
c. Hospitalizar y conducir el trabajo de aborto
d. Enviar a domicilio, indicando reposo y control
e. Realizar laparoscopía

Respuesta correcta: d. Enviar a domicilio, indicando reposo y control

Explicación: Tiene síntomas de aborto (metrorragia, sin modificaciones cervicales), además está con el embrión vivo. Solo se puede observar evolución. - La opción A (HCG y ecografía en 48 horas) es el manejo del embarazo ectópico (no tiene saco en la ecografía), con HCG menor a 1.500-3.500 (tampoco es el caso). - La opción B (ecografía en 7-14 días) es el manejo del aborto retenido, pero este no tiene metrorragia y, además, exige que haya un huevo anembrionado o un embrión sin latidos (ninguno se cumple, porque hay un embrión y tiene latidos). - Si hubiese estado sin latidos, sí se diagnosticaría un aborto retenido, por tener un embrión sin latidos mayor a 7 mm y se debería conducir el aborto (ej. misoprostol + mifepristona o AMEU) u observar, en espera del inicio espontáneo del trabajo de aborto.

Fuente: Obstetricia, cuestionario 1.1, P4

14. Una mujer de 34 años presenta metrorragia abundante. Recientemente fue diagnosticada de hipertiroidismo, por lo que está tomando propanolol. Se solicita un test de embarazo, que resulta positivo. El diagnóstico más probable es:

a. Struma ovari
b. Embarazo ectópico
c. Enfermedad de Basedow-Graves
d. Hiperplasia endometrial
e. Embarazo molar

Respuesta correcta: e. Embarazo molar

Explicación: Es el clásico caso de una mola completa: metrorragia y otros síntomas (hipertiroidismo en este caso, aunque además puede tener hiperemesis, preclamsia, quistes tecaluteínicos y mayor tamaño uterino). La mola parcial, en cambio, solo produce metrorragia.

Fuente: Obstetricia, cuestionario 1.2, P1

15. Un paciente de 34 años, se realiza un test de embarazo, el que resulta positivo. Acude a la primera ecografía obstétrica, sin embargo, no se visualiza saco gestacional. Se solicitan niveles plasmáticos de beta-HCG, que resulta 8.500 UI/L. La conducta más adecuada es:

a. Solicitar nuevos niveles de HCG y nueva ecografía en 2 días
b. Iniciar metotrexato
c. Resolver quirúrgicamente
d. Administrar misoprostol intravaginal
e. Realizar legrado uterino

Respuesta correcta: c. Resolver quirúrgicamente

Explicación: Tiene un embarazo ectópico asintomático (Ecografía que no ve saco gestacional + HCG mayor a 1.500-3.500 UI/L, según la fuente). Como tiene HCG mayor a 5.000, ya no es recomendable dar metotrexato por el riesgo de rotura del embarazo ectópico (aunque hasta 10.000 es posible darlo). El tratamiento de elección es la cirugía, que idealmente debe ser una laparoscopía y la paciente debe elegir entre hacer una salpingectomía o salpingotomía (preserva la trompa, pero tiene riesgo de un nuevo embarazo ectópico). Vale la pena mencionar que se suele enseñar que no es posible hacer el diagnóstico de embarazo ectópico no complicado solo con una HCG, pero con el valor indicado, la respuesta más correcta es la cirugía. En la vida real sería correcto que la paciente participe en la decisión, según los riesgos que quiera tomar (esperar 2 días para una nueva HCG vs. hacer ahora la laparoscopia).

Fuente: Obstetricia, cuestionario 1.2, P9

16. Una paciente es diagnosticada de un embarazo molar, mediante una ecografía transvaginal. Se realiza legrado aspirativo, con buena respuesta. La biopsia se informa como “mola completa”. La conducta más adecuada es:

a. Realizar seguimiento con niveles periódicos de beta-HCG
b. Realizar seguimiento con ecografías transvaginales periódicas
c. Realizar seguimiento con antígeno carcinoembrionario periódico
d. Indicar ACO en dosis altas por 6 meses
e. Realizar histerectomía

Respuesta correcta: a. Realizar seguimiento con niveles periódicos de beta-HCG

Explicación: Por ser una mola completa, se debe tratar, pero ya fue tratada con el legrado aspirativo. Luego se debe seguir por 1 año (la parcial se sigue por 6 meses), con niveles de HCG y además se debe dar ACO por el mismo tiempo, de modo de evitar que se embarace y positivice la HCG. Si la HCG empieza a elevarse o no decae, se hace el diagnóstico de una neoplasia trofoblástica gestacional (que obligaría a la histerectomía más QT con metotrexato, aunque antes de la cirugía igualmente se le hace una EcoTV).

Fuente: Obstetricia, cuestionario 1.2, P10

17. Una mujer cursando su primer embarazo de 12 semanas, presenta metrorragia escasa, sin otros síntomas. Al examen físico está en buenas condiciones, sin dinámica uterina y se aprecia que la metrorragia proviene del OCE. La conducta más adecuada es:

a. Realizar tactos vaginales seriados, para determinar la evolución
b. Solicitar niveles plasmáticos de beta-HCG
c. Realizar una ecografía obstétrica
d. Realizar un registro basal no estresante
e. Administrar corticoides endovenosos y antibióticos a la madre y mantener una conducta expectante

Respuesta correcta: c. Realizar una ecografía obstétrica

Explicación: Tiene una metrorragia de la primera mitad del embarazo. La conducta es hacer una especuloscopía (ya se hizo, porque dice que la sangre proviene del OCE) y luego proceder a la ecografía obstétrica (transvaginal), que diferencia entre las distintas causas (aborto, embarazo ectópico y mola) y además ve los distintos tipos de aborto (con feto vivo, con huevo irregular, etc.). Si es aborto, con feto vivo, se procede al tacto vaginal, para diferenciar entre síntomas de aborto (sin modificaciones) o aborto en evolución (con modificaciones cervicales).

Fuente: Ginecología, cuestionario 2.2, P3

18. Una mujer presenta un aborto espontáneo hace 4 meses. Desde entonces ha utilizado anticonceptivos orales. Consulta por metrorragia de 15 días de evolución, sin otros síntomas. Se solicita un test de embarazo que resulta positivo y la ecografía transvaginal muestra endometrio engrosado y miometro irregular, con áreas heterogéneas, sin visualizar un saco gestacional. El diagnóstico más probable es:

a. Embarazo ectópico
b. Síndrome de Asherman
c. Cáncer de endometrio
d. Adenomiosis
e. Neoplasia trofoblástica gestacional

Respuesta correcta: e. Neoplasia trofoblástica gestacional

Explicación: Es una NTG clásica, postaborto. Tanto las molas (lo más frecuente), como los abortos (menos frecuente) pueden originarla. Su clínica es metrorragia y se diagnostican con la HCG muy elevada. La ecografía es de ayuda: muestran el contenido endometrial irregular y puede tener formaciones de quistes, igual que la mola. El síndrome de Asherman (sinequias uterinas) es causa de amenorrea después de un legrado y tienen una ecografía con endometrio fino. El cáncer de endometrio tiene metrorragia y una ecografía concordante con el caso, pero no tiene elevación de la HCG, ni antecedente de un aborto, sino del "HONDA". La adenomiosis tiene dismenorrea e hipermenorrea, sin elevación de la HCG y la ecografía muestra el miometrio irregular.

Fuente: Ginecología, cuestionario 2.3, P13

Metrorragia del segundo y tercer trimestre (5)

19. Una paciente, cursando un embarazo de 30 semanas, presenta metrorragia escasa, sin otras alteraciones. Se realiza una especuloscopía, que confirma que la sangre proviene de la cavidad endometrial. La conducta más adecuada es:

a. Realizar cesárea de urgencia
b. Administrar corticoides endovenosos y mantener una conducta expectante
c. Solicitar ecografía obstétrica
d. Solicitar niveles plasmáticos de beta-HCG
e. Indicar reposo y observar evolución

Respuesta correcta: c. Solicitar ecografía obstétrica

Explicación: Las metrorragias de la segunda mitad del embarazo se deben estudiar con una ecografía obstétrica. No tiene clínica de DPPNI, como para interrumpir de inmediato. Es necesario que la ecografía diferencie el DPPNI de la placenta previa, que son las dos causas de metrorragia de la segunda mitad del embarazo.

Fuente: Obstetricia, cuestionario 1.2, P2

20. Una paciente de 40 años, está en trabajo de parto desde hace 6 horas. Presenta metrorragia, asociada a dolor en relación a las contracciones uterinas. El útero se palapa hipertónico y se constata un registro de la frecuencia cardiaca fetal con DIP 2 en todas las contracciones uterinas. La especuloscopía demuestra sangre saliendo del OCE. La conducta más adecuada es:

a. Realizar un tacto vaginal
b. Observar evolución
c. Administrar corticoides endovenosos
d. Administrar tocolíticos
e. Realizar cesárea de urgencia por rotura de vasa previa

Respuesta correcta: a. Realizar un tacto vaginal

Explicación: Es una pregunta complicada y discutible, pero se ha preguntado así tal cual. El cuadro clínico es evidentemente un desprendimiento de placenta (DPPNI), por lo que se debe interrumpir por la vía más expedita. El tacto vaginal es la forma de determinar la vía más expedita, por lo que es la respuesta correcta. No puede ser la E, ya que la rotura de vasa previa no tiene dolor, ni contracciones dolorosas.

Fuente: Obstetricia, cuestionario 1.2, P17

21. Una mujer de 23 años, cursando un embarazo de 30 semanas, se realiza una ecografía, que muestra la presencia de una placenta previa que cubre completamente el orificio cervical interno. La conducta más adecuada es:

a. Interrumpir el embarazo, induciendo con misoprostol
b. Administrar corticoides y mantener una conducta expectante
c. Realizar cesárea de urgencia
d. Realizar amniocentesis
e. Observar evolución e inducir con misoprostol a las 37 semanas

Respuesta correcta: b. Administrar corticoides y mantener una conducta expectante

Explicación: La placenta previa (se define como la que cubre el OCI) es indicación de cesárea, ya que contraindica absolutamente el parto vaginal. Sin embargo, su diagnóstico no se puede establecer a ciencia

cierta antes de las 32 semanas, ya que el útero puede seguir creciendo y el OCI liberarse. La conducta más adecuada es realizar control ecográfico y, con ello, se podrá definir si tendrá o no placenta previa (probablemente sí la tendrá, ya que mientras más cerca está de las 32 semanas, más probable es que se quede con ese diagnóstico). - Si estuviera sangrando profusamente o con afectación de la madre o el feto, se indicaría la cesárea. - No se puede inducir con misoprostol, porque está contraindicado el parto vaginal en este momento (ya que tiene una placenta previa actual, aunque exista la posibilidad de que cambie). - La indicación es dar corticoides (tiene menos de 34 semanas y más de 24 semanas), ya que hay algún riesgo de sangrado y, por tanto, de interrupción antes de las 34 semanas). En caso de que siga con placenta previa, se observará evolución, interrumpiendo por cesárea a las 37 semanas.

Fuente: Obstetricia, cuestionario 1.2, P20

22. Una mujer de 30 años está en trabajo de parto, en fase activa. Al momento de la rotura de membranas, se produce metrorragia, acompañada de bradicardia fetal en el registro. La conducta más adecuada es:

a. Realizar cesárea de urgencia
b. Solicitar test de Apt-Downey para determinar el origen de la sangre
c. Solicitar perfil biofísico
d. Realizar fórceps de inmediato
e. Administrar tocolíticos

Respuesta correcta: a. Realizar cesárea de urgencia

Explicación: Es una rotura de vasa previa clásica: metrorragia y sufrimiento fetal, que aparece luego de romper las membranas. Se debe proceder a una cesárea de urgencia, ya que de lo contrario, fallece el feto por shock hipovolémico, dado que la sangre es de origen fetal.

Fuente: Ginecología, cuestionario 2.1, P2

23. Una mujer cursando su primer embarazo de 32 semanas, presenta metrorragia escasa, sin otros síntomas. Al examen físico está en buenas condiciones, sin dinámica uterina. La conducta más adecuada es:

a. Realizar tactos vaginales seriados, para determinar la evolución
b. Solicitar niveles plasmáticos de beta-HCG
c. Realizar una ecografía obstétrica y un test de tolerancia a las contracciones
d. Realizar una ecografía obstétrica y un perfil biofísico
e. Administrar corticoides endovenosos a la madre e interrumpir el embarazo en 48 horas, por una cesárea

Respuesta correcta: d. Realizar una ecografía obstétrica y un perfil biofísico

Explicación: Tiene una metrorragia de la segunda mitad del embarazo. La conducta es hacer una especuloscopía (ya se hizo, porque dice que la sangre proviene del OCE) y luego proceder a la ecografía obstétrica (transvaginal), que diferencia entre las distintas causas (placenta previa y desprendimiento prematuro de placenta normoinserta). Además, es correcto evaluar el bienestar fetal, con el RBNE o PBF.

Fuente: Ginecología, cuestionario 2.1, P3

Parto prematuro y rotura prematura de membranas (8)

24. Una mujer de 28 años, primigesta, cursando un embarazo de 33 semanas de edad gestacional, inicia contracciones uterinas. Al examen físico se constatan 2 contracciones cada 10 minutos y un cuello uterino

con 50% de borramiento y 1 cm de dilatación. Las pruebas de bienestar fetal son tranquilizadoras. La conducta más adecuada es:

a. Observar y dejar a evolución espontánea
b. Administrar corticoides sistémicos y tocolíticos, y mantener una conducta expectante
c. Interrumpir el embarazo mediante cesárea
d. Iniciar goteo oxitócico
e. Solicitar ecografía obstétrica

Respuesta correcta: b. Administrar corticoides sistémicos y tocolíticos, y mantener una conducta expectante

Explicación: Tiene un trabajo de parto prematuro, menor a 34 semanas, por lo que se debe manejar con tocolíticos y corticoides. Si tuviese 34 semanas o más, se manejaría con evolución espontánea. Antes del tacto vaginal, habría sido recomendable hacer una cervicometría, de modo de evaluar la longitud cervical.

Fuente: Obstetricia, cuestionario 1.1, P3

25. Una mujer de 35 años, cursando un embarazo de 30 semanas, presenta salida de abundante líquido claro por genitales. A la especuloscopía no hay cambios y se realiza test de cristalización, el que resulta positivo. El registro basal no estresante resulta reactivo. La conducta más adecuada es:

a. Interrumpir el embarazo
b. Administrar corticoides sistémicos y enviar a domicilio con tratamiento antibiótico oral
c. Administrar corticoides sistémicos y tocolíticos
d. Hospitalizar, administrar corticoides sistémicos y antibióticos
e. Hospitalizar, administrar corticoides sistémicos, antibióticos y tocolíticos

Respuesta correcta: d. Hospitalizar, administrar corticoides sistémicos y antibióticos

Explicación: Tiene una rotura prematura de membranas (RPM o RPO), menor de 34 semanas (tiene 30 semanas), por lo que se debe manejar con antibióticos, corticoides y una conducta expectante. Se debe hospitalizar. Si hubiese tenido más de 34 semanas, se habría tenido que interrumpir. Los tocolíticos están contraindicados en la rotura de membrana y solo se indican en el parto prematuro menor a 34 semanas, con membranas íntegras.

Fuente: Obstetricia, cuestionario 1.1, P17

26. Una paciente de 24 años, primigesta, cursando un embarazo de 35 semanas, con edad gestacional segura, consulta por contracciones uterinas. Al examen físico presenta una dinámica de 2 contracciones cada 10 minutos, la cervicometría demuestra cuello completamente borrado y se palpa dilatación cervical de 2 cm. El perfil biofísico es tranquilizador. La conducta más adecuada es:

a. Observar evolución
b. Realizar amniocentesis
c. Administrar corticoides endovenosos y tocolíticos
d. Administrar tocolíticos endovenosos
e. Iniciar oxitocina en goteo

Respuesta correcta: a. Observar evolución

Explicación: Es un trabajo de parto prematuro (dinámica uterina y dilatación cervical), que, por tener más de 34 semanas, se debe dejar a evolución espontánea. No requiere corticoides ni tocolíticos, sino solo la ampicilina, como profilaxis de SGB. La amniocentesis está indicada en los casos en que han fallado los

tocolíticos de primera línea o antes de indicarlos, si es que la cervicometría tiene un cuello menor a 15 mm. Por no estar indicados los tocolíticos, tampoco se indica la anmiocentesis, a pesar de que tenga menos de 15 mm de longitud cervical (tiene 0 mm).

Fuente: Obstetricia, cuestionario 1.2, P3

27. Una paciente de 24 años, cursando un embarazo de 31 semanas, presenta escasa salida de líquido por genitales. Se realiza test pack de detección de alfa 1 microglobulina placentaria (PAMG-1), que resulta positivo. El tacto vaginal muestra cuello uterino cerrado, duro y posterior. La conducta más adecuada es:

a. Inducir con misoprostos
b. Inducir con oxitocina
c. Administrar corticoides y antibióticos y mantener una conducta expectante
d. Realizar cesárea
e. Dejar evolución espontánea

Respuesta correcta: c. Administrar corticoides y antibióticos y mantener una conducta expectante

Explicación: Es una RPM o RPO (ya está confirmada por la positividad de la PAMG1), por lo que se debe tratar. Por tener menos de 34 semanas, se debe mantener una conducta expectante, administrando corticoides y antibióticos. Si fuera mayor a 34 semanas, sí se interrumpiría.

Fuente: Obstetricia, cuestionario 1.2, P16

28. Una paciente de 25 años, con antecedente de un parto prematuro, cursa su segundo embarazo, de 32 semanas. Presenta salida de líquido claro por genitales. La especuloscopía resulta normal y el test de cristalización es positivo. La conducta más adecuada es:

a. Interrumpir el embarazo
b. Administrar corticoides y tocolíticos
c. Administrar corticoides y antibióticos a la madre y hospitalizar, manteniendo una conducta expectante
d. Administrar corticoides a la madre y enviar a domicilio, indicando antibióticos orales
e. Administrar antibióticos y corticoides e interrumpir el embarazo en 48 horas

Respuesta correcta: c. Administrar corticoides y antibióticos a la madre y hospitalizar, manteniendo una conducta expectante

Explicación: Tiene una RPM menor a 32 semanas, por lo que se debe manejar de manera expectante, con antibióticos y corticoides. Se interrumpirá al cumplir las 34 semanas o si desarrolla clínica de corioamnionitis. La opción E (coriticoides + ATB + interrumpir en 48 h) es aceptable entre las 32 y 34 semanas, pero actualmente se prefiere mantener una conducta expectante.

Fuente: Ginecología, cuestionario 2.1, P1

29. Una mujer de 20 años, cursando un embarazo de 33 semanas, inicia contracciones uterinas, algunas de las cuales son dolorosas. Se constata la presencia de 2 contracciones uterinas cada 10 minutos y el registro de la frecuencia fetal es tranquilizador. El tacto vaginal no muestra modificaciones cervicales. La conducta más adecuada es:

a. Realizar una amniocentesis
b. Realizar una ecografía transvaginal
c. Enviar a domicilio
d. Administrar nifedipino oral

e. Administrar corticoides, tocolíticos y antibióticos endovenosos

Respuesta correcta: b. Realizar una ecografía transvaginal

Explicación: Tiene una amenaza de parto prematuro (contracciones, sin modificaciones cervicales, antes de las 37 semanas). Además, es menor a 34 semanas, por lo que se debe realizar una cervicometría, para determinar el riesgo de evolución a un trabajo de parto prematuro. Si tuviese 30 mm o más de longitud cervical, se observaría evolución. Si tiene menos, se debe manejar con tocolíticos y corticoides. La amniocentesis solo se indica si tiene menos de 15 mm o si no responde a los tocolíticos de primera línea.

Fuente: Ginecología, cuestionario 2.1, P4

30. Una paciente de 25 años, con antecedente de un parto prematuro, cursa su segundo embarazo, de 36 semanas. Presenta salida de líquido claro por genitales. La especuloscopía resulta normal y el test de cristalización es positivo. Al examen obstétrico se aprecia feto en cefálica, sin modificaciones cervicales y el RBNE es reactivo. La conducta más adecuada es:

a. Interrumpir el embarazo
b. Administrar antibióticos y tocolíticos
c. Administrar corticoides y antibióticos a la madre y hospitalizar, manteniendo una conducta expectante
d. Administrar corticoides a la madre y enviar a domicilio, indicando antibióticos orales
e. Administrar antibióticos y corticoides e interrumpir el embarazo en 48 horas

Respuesta correcta: a. Interrumpir el embarazo

Explicación: Tiene una RPM mayor a 34 semanas, por lo que se debe interrumpir. En este caso, no hay contraindicaciones para el parto vaginal, por lo que se debe interrumpir con misoprostol.

Fuente: Ginecología, cuestionario 2.2, P1

31. Una mujer de 20 años, cursando un embarazo de 33 semanas, inicia contracciones uterinas, algunas de las cuales son dolorosas. Se constata la presencia de 2 contracciones uterinas cada 10 minutos y el registro de la frecuencia fetal es tranquilizador. El tacto vaginal muestra dilatación cervical de un centímetro. La conducta más adecuada es:

a. Realizar rotura artificial de membranas
b. Realizar una ecografía transvaginal
c. Enviar a domicilio
d. Administrar labetalol y corticoides endovenoso
e. Administrar corticoides y tocolíticos endovenosos

Respuesta correcta: e. Administrar corticoides y tocolíticos endovenosos

Explicación: Tiene un trabajo de parto prematuro (contracciones y modificaciones cervicales, antes de las 37 semanas). Además, es menor a 34 semanas, por lo que se debe manejar con tocolíticos y corticoides. Si tuviese más de 34 semanas, se observaría evolución.

Fuente: Ginecología, cuestionario 2.2, P4

Síndrome hipertensivo del embarazo (5)

32. Una paciente de 18 años, cursando un embarazo de 33 semanas de edad gestacional, consulta por marcado compromiso del estado general, asociado a dolor abdominal, vómitos e ictericia, que iniciaron hace dos días. Al examen físico presenta presión arterial 150/100 e ictericia de piel y mucosas. En sus

exámenes destaca GOT: 400 UI/L, bilirrubina: 7,3 mg/dl, fracción directa: 30%, hematocrito: 28%, LDH: 1.200 UI/L. El diagnóstico más probable es:

a. Hígado graso agudo del embarazo
b. Colestasia intrahepática del embarazo
c. Listeriosis
d. Corioamnionitis clínica
e. Síndrome de HELLP

Respuesta correcta: e. Síndrome de HELLP

Explicación: Por la clínica puede ser tanto un hígado graso agudo del embarazo, como un síndrome de HELLP. Sin embargo, la hipertensión arterial, la anemia y la elevación de la LDH (hemólisis), sugiere más un síndrome de HELLP. La CIE tiene prurito palmoplantar, con colestasia en las pruebas hepáticas, sin hepatitis.

Fuente: Obstetricia, cuestionario 1.1, P10

33. Una paciente con antecedente de preclamsia severa, está en trabajo de parto a la semana 35+0. Presenta 4 contracciones uterinas cada 10 minutos y su cuello tiene 10 cm de dilatación, con feto en presentación cefálica, en espinas 0. Además, recibe sulfato de magnesio endovenoso por su patología de base. El monitoreo de la frecuencia cardíaca fetal (FCF) muestra una caída de la FCF, tal como se muestra en la figura. La conducta más adecuada es:

a. Iniciar aceleración oxitócica
b. Administrar tocolíticos
c. Mantener una conducta expectante
d. Realizar fórceps
e. Realizar cesárea de urgencia

Respuesta correcta: e. Realizar cesárea de urgencia

Explicación: Tiene un registro MEFI III (ominoso), por presencia de una bradicardia mantenida (mayor a 10 min) y variabilidad ausente. Por tanto, se debe interrumpir de inmediato, por la vía más expedita. Vale la pena mencionar que el MEFI III se maneja con reanimación intrauterina (O2 materno, suspender la oxitocina y lateralizar a izquierda), y solo si no responde rápidamente, se interrumpe por la vía más expedita (se espera que responda en algunos minutos, fijándose como máximo 30 minutos, pero pudiendo ser menos, según el registro, como ocurre en la bradicardia mantenida, mayor a 10 minutos, en que se procede a interrumpir). La vía más expedita puede ser una cesárea de urgencia (si no se dan las condiciones para un fórcep, como en este caso) o bien un fórceps (si se dan las condiciones obstétricas: 10 cm de dilatación, cefálica, descenso en trecer plano de Hodge o espinas + 2).

Fuente: Obstetricia, cuestionario 1.1, P19

34. Una paciente de 20 años, cursando un embarazo de 32 semanas, es diagnosticada de un síndrome hipertensivo del embarazo, mediante una semihospitalización, que presenta varias presiones arteriales cercanas a 150/100 mmHg. Se solicita una proteinuria cuantitativa, que resulta 500 mg/día. La conducta más adecuada es:

a. Hospitalizar, solicitar exámenes de severidad de preclamsia y administrar corticoides endovenosos a la madre
b. Iniciar alfametildopa y controlar ambulatoriamente
c. Administrar labetalol endovenoso de inmediato

d. Administrar sulfato de magnesio intravenoso de inmediato
e. Realizar interrupción del embarazo

Respuesta correcta: a. Hospitalizar, solicitar exámenes de severidad de preclamsia y administrar corticoides endovenosos a la madre

Explicación: Por tener una semihospitalización positiva, está hecho el diagnóstico de síndrome hipertensivo del embarazo. Tiene más de 20 semanas, así que puede ser preclamsia. Como tiene la proteinuria positiva (mayor a 300 mg/24 horas) es una preclamsia con seguridad. Se debe hospitalizar y solicitar los exámenes de severidad. Además, como tiene menos de 34 semanas, están obligados los corticoides y se debe estudiar, además, con un doppler fetal.

Fuente: Obstetricia, cuestionario 1.2, P13

35. Una mujer de 19 años, cursando un embarazo de 30 semanas, consulta por dolor abdominal. En las últimas semanas ha sentido malestar general, el que empeoró mucho en las últimas 24 horas. Al examen físico se aprecia algo ictérica, con PA: 190/120, edema en las extremidades inferiores. Sus exámenes demuestran anemia leve, plaquetas: 50.000, proteinuria cualitativa ++++, GOT: 280 UI/L, creatinina: 2,0 mg/dl. El RBNE es reactivo. La conducta más adecuada es:

a. Administrar labetalol y sulfato de magnesio, por vía endovenosa y realizar cesárea
b. Administrar fenoterol por vía endovenosa e interrumpir el embarazo por la vía más expedita
c. Administrar labetalol y corticoides por vía endovenosa y mantener una conducta expectante hasta las 34 semanas
d. Administrar fenoterol por vía endovenosa e inducir el parto con misoprostol intravaginal
e. Administrar nifedipino por vía oral y realizar cesárea de urgencia

Respuesta correcta: a. Administrar labetalol y sulfato de magnesio, por vía endovenosa y realizar cesárea

Explicación: Tiene un síndrome de HELLP clásico: preclamsia (HTA, con proteinuria y edema), anemia, trombopenia y hepatitis (además, el dolor epigástrico es característico). Se trata con interrupción (en este caso cesárea, por no tener un trabajo de parto avanzado, por lo que demoraría mucho la inducción), pero previamente se debe administrar el sulfato de magnesio. Además tiene una crisis hipertensiva (PA > o = a 160/110 mmHg), que se maneja con labetalol ev. El fenoterol es un beta-agonista, que se usa como tocolítico de segunda línea.

Fuente: Ginecología, cuestionario 2.1, P6

36. Una mujer de 19 años, cursando un embarazo de 30 semanas, consulta por dolor abdominal. En las últimas semanas ha sentido malestar general, el que empeoró mucho en las últimas 24 horas. Al examen físico se aprecia algo ictérica, con PA: 190/120, edema en las extremidades inferiores. Sus exámenes demuestran anemia leve, plaquetas: 50.000, proteinuria cualitativa ++++, GOT: 280 UI/L, creatinina: 2,0 mg/dl. El RBNE es reactivo. El diagnóstico es:

a. Síndrome de HELLP
b. Colestasia intrahepática del embarazo
c. Hígado graso agudo del embarazo
d. Rotura uterina
e. Corioamnionitis

Respuesta correcta: a. Síndrome de HELLP

Explicación: Tiene un síndrome de HELLP clásico: preclamsia (HTA, con proteinuria y edema), anemia, trombopenia y hepatitis (además, el dolor epigástrico es característico). Además tiene una crisis hipertensiva (PA > o = a 160/110 mmHg). La CIE tiene prurito palmoplantar y a los más, colestasia en el laboratorio. El HGAE tiene una hepatitis severa, con gran malestar general, tendencia a las hipoglicemias y a la falla hepática, sin las cosas mencionadas en el HELLP.

Fuente: Ginecología, cuestionario 2.2, P6

Diabetes gestacional (3)

37. Una paciente de 40 años, cursando un embarazo de 28 semanas, se realiza un TTGO con 75 gramos de glucosa, que resulta 100 mg/dl basal y 135 mg/dl a las 2 horas. La conducta más adecuada es:

a. Observar evolución
b. Administrar corticoides endovenosos a la madre
c. Repetir el TTGO
d. Iniciar insulinoterapia
e. Iniciar dieta y ejercicio y controlar frecuentemente con hemoglucotest

Respuesta correcta: e. Iniciar dieta y ejercicio y controlar frecuentemente con hemoglucotest

Explicación: Tiene una diabetes mellitus gestacional, dado que la glicemia basal está en 100 (mayor o igual a 100 es diagnóstico, aunque la glicemia postcarga esté normal; posterga mayor o igual a 140 también es diagnóstica de DMG). Inicialmente se trata con dieta y ejercicio y de segunda línea se usa la insulina NPH + cristalina en esquema intensificado (no se usa la insulina glargina); los hipoglicemiantes orales han demostrado ser seguros en el embarazo, en específico la metformina y glibenclamida. Es una pregunta muy difícil y odiosa, por estar en el límite y tener la glicemia postcarga normal.

Fuente: Obstetricia, cuestionario 1.2, P6

38. Una mujer de 40 años, cursando un embarazo de 32 semanas presenta polihidramnios, por lo que se realiza un test de tolerancia a la glucosa que muestra glicemia basal de 110 mg/dl y una glicemia 2 horas post 75 g de glucosa de 180 mg/dl. Se indica dieta. ¿Cuál es el mejor examen para evaluar el control metabólico de esta paciente?

a. Test de tolerancia a la glucosa
b. Glicemia de ayuno
c. Hemoglobina glicosilada
d. Glicemias preprandiales y postprandiales
e. Ecografía obstétrica, con estimación de peso fetal

Respuesta correcta: d. Glicemias preprandiales y postprandiales

Explicación: La diabetes gestacional (DMG) se diagnostica como 2 glicemias mayores a 100, pero menores a 126 (al inicio del embarazo); si son de 126 o más, se diagnostica una diabetes pregestacional (DMPG). La DMG también se diagnostica en la segunda mitad del embarazo, como un TTGO 75 gramos de glucosa, con glicemia basal de 100 mg/dl o más, o con la glicemia postcarga de 140 mg/dl o más. En este caso, tanto por la glicemia basal, como por la postcarga, tiene una DMG. - Se debe evaluar con glicemias capilares pre y postprandiales (mínimo 4 al día), las que deben ser 60-90 y 90-120, respectivamente. Se controla cada 2 semanas para determinar si el tratamiento es el adecuado. La HbA1c no sirve en el embarazo, por demorar mucho en alterarse o en mejorar, pero aún así, vale la pena mencionar, que lo ideal, es que sea menor a 6% (se es bastante estricto en el embarazo).

Fuente: Ginecología, cuestionario 2.1, P7

39. Una mujer de 40 años, cursando un embarazo de 32 semanas presenta polihidramnios, por lo que se realiza un test de tolerancia a la glucosa que muestra glicemia basal de 90 mg/dl y una glicemia 2 horas post 75g de glucosa de 130 mg/dl. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

a. Solicitar nuevo test de tolerancia a la glucosa, con 100 gramos
b. Solicitar glicemia de ayuno
c. Solicitar emoglobina glicosilada
d. Descartar la Diabetes, como causa del polihidroamnios
e. Solicitar test de tolerancia a las contracciones

Respuesta correcta: d. Descartar la Diabetes, como causa del polihidroamnios

Explicación: La diabetes gestacional se disgnostica como 2 glicemias mayores a 100, pero menores a 126 (al inicio del embarazo). También se diagnostica en la segunda mitad del embarazo, como un TTGO 75 gramos de glucosa, con glicemia basal de 100 mg/dl o más, o con la glicemia postcarga de 140 mg/dl o más. En este caso, está estrictamente normal, así que no hay diabetes.

Fuente: Ginecología, cuestionario 2.2, P7

Trabajo de parto y monitorización fetal (10)

40. Una mujer de 40 años, cursando su cuarto embarazo, de 40 semanas, inicia trabajo de parto, con feto en presentación cefálica. Mientras estaba en fase de expulsivo inicia dolor abdominal intenso, asociado a metrorragia escasa. Además, se constata cese de las contracciones uterinas. Su embarazo actual no tuvo complicaciones y su parto anterior fue por cesárea, debido a presentación podálica. Se constata que el registro cardiotocográfico muestra una frecuencia cardiaca fetal basal a 60x'. El diagnóstico más probable es:

a. Rotura de vasa previa
b. Desprendimiento prematuro de placenta normoinserta
c. Acretismo placentario
d. Placenta previa
e. Rotura uterina

Respuesta correcta: e. Rotura uterina

Explicación: Es una rotura uterina clásica: antecedente de cesárea previa, con metrorragia en el parto y cese de las contracciones uterinas más sufrimiento fetal. La rotura de vasa previa tiene metrorragia y sufrimiento fetal luego de la rotura de membranas, sin dolor ni afectación materna. El DPPNI tiene contracciones dolorosas, metrorragia y sufrimiento fetal, pero las contracciones no cesan. El acretismo presenta imposibilidad de expulsar la placenta, con abundante metrorragia luego del nacimiento, que obliga a una histerectomía. La placenta previa solo tiene metrorragia abundante, generalmente antes del parto (en la segunda mitad del embarazo)

Fuente: Obstetricia, cuestionario 1.1, P1

41. Una mujer de 20 años cursando un embarazo de 40 semanas de gestación, inicia trabajo de parto, por lo que es ingresada a la sala de parto, administrándose anestesia raquídea. En una evaluación presenta dilatación completa, con feto en presentación de vértice, en el primer plano de Hodge, con membranas rotas y 4 contracciones cada 10 minutos. El registro fetal es tranquilizador. Se vuelve a evaluar 2 horas después, sin tener ningún cambio. La conducta más adecuada es:

a. Realizar cesárea

b. Realizar fórceps
c. Iniciar goteo oxitócico
d. Administrar metilergonovina
e. Mantener conducta expectante

Respuesta correcta: a. Realizar cesárea

Explicación: Tiene un expulsivo detenido: 10 cm de dilatación, sin descenso en 2 horas. Se debe realizar una prueba de trabajo de parto, sin embargo, dicha prueba ya se realizó espontáneamente, ya que tiene 1. Buena dinámica (3 a 5 CU en 10 min), por lo que no requiere oxitocina, 2. Membranas rotas, por lo que no se pueden romper y 3. Anestesia. Por lo tanto, ya tiene diagnosticada la desproporción cefalopélvica y se debe proceder a la cesárea.

Fuente: Obstetricia, cuestionario 1.1, P14

42. Durante un trabajo de parto se realiza monitorización de la frecuencia cardíaca fetal. Se aprecia que en relación a la mayoría de las contracciones uterinas aparecen desaceleraciones en espejo con estas (desaceleraciones precoces). La conducta más adecuada es:

a. Dejar a evolución espontánea
b. Iniciar aceleración oxitócica
c. Administrar tocolíticos
d. Realizar rotura artificial de membranas
e. Interrumpir el embarazo por la vía más expedita

Respuesta correcta: a. Dejar a evolución espontánea

Explicación: Las desaceleraciones precoces o DIP I se consideran normales y por tanto es un MEFI I, que se debe observar.

Fuente: Obstetricia, cuestionario 1.1, P15

43. Una paciente presenta un embarazo de 40 semanas, que está en trabajo de parto. Al momento de la rotura de membrana, se produce salida de líquido amniótico claro, pero evoluciona rápidamente con deterioro del registro fetal, el que muestra una bradicardia fetal mantenida. El diagnóstico de sospecha es:

a. Rotura uterina
b. Rotura de vasa previa
c. Abruptio placentae
d. Placenta previa
e. Procidencia de cordón umbilical

Respuesta correcta: e. Procidencia de cordón umbilical

Explicación: Todas las demás producen metrorragia. La procidencia de cordón se caracteriza por sufrimiento fetal, que aparece al romper las membranas (se debe hacer un tacto vaginal urgente, que permite hacer el diagnóstico y presionar la cabeza fetal, para descomprimir el cordón, mientras se va a la cesárea). Si viniera con metrorragia, sería una rotura de vasa previa (metrorragia y sufrimiento fetal luego de la rotura de membranas).

Fuente: Obstetricia, cuestionario 1.2, P12

44. Una paciente está en trabajo de parto, con dinámica uterina espontánea y ha permanecido en decúbito lateral izquierdo. El registro fetal muestra el siguiente trazado, desde hace 30 minutos: Su tacto

vaginal muestra membranas íntegras, con 10 cm de dilatación, en espinas 0. La conducta más adecuada es:

a. Realizar cesárea de urgencia
b. Realizar rotura de membrana
c. Iniciar goteo oxitócico
d. Dejar a evolución espontánea
e. Realizar fórceps

Respuesta correcta: a. Realizar cesárea de urgencia

Explicación: Tiene desaceleraciones tardías en todas las contracciones uterinas y además tiene una variabilidad mínima. Por tanto es un MEFI 3 (ominoso), que requiere interrupción por la vía más expedita, ya que se cumplen los criterios de reanimación intrauterina (lateralizar, suspender la oxitocina y dar O2: el único que falta; además, ninguna de las opciones contiene la reanimación intrauterina). Si bien tiene dilatación completa, el descenso fetal es menor a espinas +2, por lo que no se puede hacer fórceps. Por tanto, se debe hacer cesárea de urgencia. Está contraindicado administrar goteo oxitócio. La rotura de membranas podría mostrar meconio, pero no cambia la conducta, porque ya está hecho el diagnóstico de sufrimiento fetal.

Fuente: Obstetricia, cuestionario 1.2, P15

45. Una paciente está en trabajo de parto, a las 38 semanas. Presenta 4 CU en 10 minutos, feto en cefálica, con membranas íntegras, 6 cm de dilatación, borramiento completo y descenso en espinas -2. El registro fetal es tranquilizador (MEFI 1). Usted la evalúa 2 horas después y persiste sin cambios. La conducta más adecuada es:

a. Observar evolución
b. Realizar rotura de membranas
c. Iniciar oxitocina en goteo endovenoso
d. Realizar fórceps
e. Realizar cesárea

Respuesta correcta: b. Realizar rotura de membranas

Explicación: Como no ha avanzado adecuadamente (al estar en fase activa, debió haber dilatado al menos 2 cm en las dos horas), se debe hacer una prueba de trabajo de parto, que consiste en 1. dar anestesia (no aparece en el caso, ni en las opciones), 2. dar aceleración oxitócica para lograr 3 a 5 CU en 10 minutos (ya tiene 4 CU en 10 minutos, por lo que no está indicada) y 3. Romper las membranas (en este caso están íntegras, por lo que se deben romper).

Fuente: Obstetricia, cuestionario 1.2, P18

46. Una mujer multípara está en trabajo de parto a las 40 semanas. Presenta 3 contracciones cada 10 minutos, feto en cefálica, cuello uterino completamente borrado, con dilatación de 5 cm y membranas íntegras. Tres horas después tiene una dilatación de 6 cm. La conducta más adecuada es:

a. Realizar rotura de membranas
b. Dejar evolucionar espontáneamente
c. Realizar cesárea
d. Realizar fórceps
e. Iniciar goteo oxitócico

Respuesta correcta: a. Realizar rotura de membranas

Explicación: Por estar en fase activa, se espera que en 3 horas haya dilatado al menos 3 cm. Como no ocurrió, se debe hacer una prueba de trabajo de parto: 1. oxitocina para tener 3 a 5 contracciones en 10 minutos (ya las tiene), 2. rotura de membranas (se debe hacer en este caso) y 3. anestesia (no está en las opciones, así que se asume que ya la tiene). Solo si no avanza, se debe hacer la cesárea, por desproporción cefalopélvica.

Fuente: Ginecología, cuestionario 2.1, P9

47. Una paciente multípara, cursando un embarazo de término, inicia trabajo de parto, en fase de expulsivo, con feto en presentación de vértice y 4 contracciones cada 10 minutos. Como antecedente tiene dos cesáreas previas a las 40 y 36 semanas respectivamente. La conducta más adecuada es:

a. Realizar cesárea
b. Dejar evolución espontánea
c. Realizar fórceps
d. Administrar tocolíticos
e. Administrar corticoides y tocolíticos

Respuesta correcta: a. Realizar cesárea

Explicación: Por tener 2 cesáreas previas, está contraindicado el parto vaginal, por riesgo de rotura uterina. Por ello, se debe hacer cesárea.

Fuente: Ginecología, cuestionario 2.1, P10 · Ginecología, cuestionario 2.2, P10

48. Una mujer de 30 años está en trabajo de parto, en fase activa. Al momento de la rotura de membranas, se produce bradicardia fetal mantenida en el registro, hasta 70 lpm, sin metrorragia, ni dolor materno. El diagnóstico más probable es:

a. Rotura uterina
b. Desprendimiento de placenta
c. Rotura de vasa previa
d. Procidencia de cordón
e. Reacción vagal normal

Respuesta correcta: d. Procidencia de cordón

Explicación: Es una procidencia de cordón clásica: sufrimiento fetal, que aparece luego de romper las membranas. Se debe hacer un tacto vaginal, para descomprimir el cordón y proceder a una cesárea de urgencia. La rotura de vasa previa puede ser igual, pero con metrorragia. El desprendimiento de placenta ex-vacuo puede ser similar, pero con metrorragia, contracciones dolorosas e hipertonía uterina.

Fuente: Ginecología, cuestionario 2.2, P2

49. Una mujer multípara está en trabajo de parto en fase activa. Presenta 2 contracciones cada 10 minutos, feto en cefálica, cuello uterino completamente borrado, con dilatación de 5 cm y membranas rotas. Dos horas después se mantiene igual. La conducta más adecuada es:

a. Realizar episiotomía
b. Dejar evolucionar espontáneamente
c. Realizar cesárea
d. Realizar fórceps
e. Iniciar goteo oxitócico

Respuesta correcta: e. Iniciar goteo oxitócico

Explicación: Se asume que es un parto de término, ya que no le dan importancia a la edad gestacional (no la indican). Por estar en fase activa, se espera que en 2 horas haya dilatado al menos 2 cm. Como no ocurrió, se debe hacer una prueba de trabajo de parto: 1. oxitocina para tener 3 a 5 contracciones en 10 minutos (solo tiene dos), 2. rotura de membranas (ya están rotas, así que no se puede hacer) y 3. anestesia (no está en las opciones, así que se asume que ya la tiene). Solo si no avanza, se debe hacer la cesárea, por desproporción cefalopélvica.

Fuente: Ginecología, cuestionario 2.2, P9

Puerperio y hemorragia postparto (2)

50. Una mujer de 25 años, primípara, consulta tres días después del parto por aumento de volumen y dolor, en relación a la cara anterior de axila. Al examen físico se aprecia una masa redonda de 5 cm de diámetro, tensa, muy dolorosa a la palpación, con escaso eritema en la piel que la recubre. La conducta más adecuada es:

a. Indicar agonistas dopaminérgicos (bromocriptina / cabergolina)
b. Educar, indicar analgésicos y observar evolución
c. Indicar antibióticos endovenosos
d. Programar cirugía electiva
e. Resolver quirúrgicamente bajo cobertura antibiótica

Respuesta correcta: b. Educar, indicar analgésicos y observar evolución

Explicación: La clínica sugiere una glándula mamaria accesoria, que suele ser de buen pronóstico y que se resuelve espontáneamente (al menos cede el dolor), en unos días. Los dopaminérgicos se usan para suspender la lactancia. La mastitis (eritema en la mama) y el absceso mamario (dolor y aumento de volumen con eritema en la mama, no en la axila) sí se tratan con antibióticos (el absceso, además, se drena con cirugía).

Fuente: Obstetricia, cuestionario 1.1, P9

51. Una mujer presenta abundante metrorragia, inmediatamente después del parto, sin dolor. Es posible palpar el fondo uterino entre el ombligo y la apófisis xifoides. El diagnóstico más probable es:

a. Hematoma vaginal
b. Restos ovulares
c. Rotura uterina
d. Inercia uterina
e. Laceración del canal del parto

Respuesta correcta: d. Inercia uterina

Explicación: La inercia uterina o atonía uterina es la causa más frecuente de hemorragia puerperal precoz. Además, se caracteriza por tener el útero distendido (por sobre el ombligo). Si hubiese dicho que el útero estaba retraído o a la altura del ombligo (o bajo el ombligo), la respuesta habría sido laceración del canal, ya que es la segunda causa.

Fuente: Obstetricia, cuestionario 1.1, P11

Infecciones durante el embarazo (5)

52. ¿Cuál de los siguientes antibióticos le parece más adecuado para el tratamiento de una pielonefritis aguda durante el embarazo?

a. Ceftriaxona endovenosa
b. Ciprofloxacino oral
c. Nitrofurantoína oral
d. Metronidazol endovenoso
e. Ampicilina endovenosa

Respuesta correcta: a. Ceftriaxona endovenosa

Explicación: En el embarazo, las pielonefritis se deben hospitalizar y tratar con antibióticos, por vía endovenosa, que cubran las bacterias habituales de ITU. Generalmente se iniciaba con cefazolina (primera generación), ya que tienen buena cobertura para Gram negativos, aunque actualmente se recomienda tratar con ceftriaxona (tercera generación) o cefepime (cuarta generación). Si son alérgicas, se pueden usar los aminoglicósidos (gentamicina) o el astreonam (más usado en la actualidad). El ciprofloxacino está contraindicado en el embarazo. La ITU baja se puede tratar con cefalosporinas orales (cefradina o cefadroxilo) y si es alérgica con nitrofurantoína. Vale la pena mencionar que tanto la nitrofurantoína, como los aminoglicósidos, deben evitarse, en lo posible, en el embarazo.

Fuente: Obstetricia, cuestionario 1.1, P12

53. La profilaxis de sepsis neonatal por estreptococo grupo B, con ampicilina intravenosa durante el trabajo de parto, en una mujer que no se realizó el cultivo perineal a las 35-35 semanas, está indicada en una de las siguientes situaciones. ¿Cuál es?

a. Más de 42 semanas de edad gestacional
b. Diabetes mellitus gestacional
c. Fiebre materna
d. Preclamsia
e. Restricción del crecimiento intrauterino

Respuesta correcta: c. Fiebre materna

Explicación: Las indicaciones de profilaxis son: * Siempre (con o sin cultivo): sepsis neonatal previa por SGB, UCT(+) para SGB. El Minsal, además, incluye al parto prematuro. * Cultivo perineal positivo para SGB. * Sin realización de cultivo, más fiebre materna (más que profilaxis, se considera tratamiento, por lo que el esquema antibiótico es más amplio: ampicilina + gentamicina) o RPM mayor a 18 horas. En muchas guías internacionales el parto prematuro es indicación en esta situación (no realización de cultivo). Nota aclaratoria: el parto prematuro, en la práctica, es indicación de profilaxis por el simple hecho de que no se alcanza a tener el resultado del cultivo, que precisamente se pide a las 36 semanas. Además, la prematurez es el factor de riesgo más importante para sepsis neonatal.

Fuente: Obstetricia, cuestionario 1.1, P13

54. Una paciente cursando un embarazo de 29 semanas presenta fiebre y malestar general, asociada a leucorrea. Al examen físico de la paciente se constata FC: 105x', PA: 120/70 mmHg, t°: 38,5°C, sensibilidad a la palpación uterina y la especuloscopía demuestra que la leucorrea proviene del OCE. Las pruebas de bienestar fetal son tranquilizadoras. La conducta más adecuada es:

a. Administrar gentamicina + clindamicina por vía endovenosa y realizar cesárea

b. Administrar corticoides sistémicos y antibióticos intraamnióticos e interrumpir el embarazo al alcanzar las 32 semanas.

c. Administrar antibióticos por vía endovenosa y mantener una conducta expectante

d. Administrar corticoides y antibióticos sistémicos y mantener una conducta expectante

e. Realizar amniocentesis de urgencia y decidir conducta según hallazgos

Respuesta correcta: a. Administrar gentamicina + clindamicina por vía endovenosa y realizar cesárea

Explicación: Tiene una corioamnionitis clínica clásica: fiebre materna (>37,8°C) más al menos 2 de los siguientes criterios: leucorrea, taquicardia materna, dolor a la palpación uterina, taquicardia fetal (no está en este caso), leucocitosis (no aparece en este caso). También cumple con los criterios modernos: fiebre materna (>38°C) más al menos uno de los siguientes: leucorrea, taquicardia fetal o leucocitosis. Por lo que se cumple el diagnóstico de sospecha, que es suficiente para tratar. El diagnóstico definitivo se realiza con la amniocentesis o la biopsia de la placenta. El tratamiento es la interrupción bajo cobertura antibiótica (idealmente con ampicilina más gentamicina más clindamicina, si se hace cesárea; otros indican clindamicina más gentamicina de entrada). La vía de parto puede ser vaginal, si es que está en trabajo de parto o si es que se puede inducir. Si está contraindicado el parto vaginal o si hay compromiso fetal (ej. taquicardia fetal, sufrimiento fetal), se debe interrumpir por cesárea, dada su rapidez.

Fuente: Obstetricia, cuestionario 1.1, P18

55. Una mujer de 19 años, cursando un embarazo de 34 semanas consulta por fiebre alta y malestar general, asociada a disuria intensa. Se solicitan exámenes de orina, que muestran abundantes bacterias y leucocitos urinarios. El urocultivo está pendiente. La conducta más adecuada es:

a. Indicar cefadroxilo oral y controlar ambulatoriamente

b. Indicar ciprofloxacino oral y controlar ambulatoriamente

c. Indicar nitrofurantoína oral y controlar ambulatoriamente

d. Iniciar ceftriaxona endovenosa

e. Observar evolución, a la espera del urocultivo

Respuesta correcta: d. Iniciar ceftriaxona endovenosa

Explicación: Es una pielonefritis aguda. En el embarazo se tratan con medicamentos endovenosos. En especial cefalosporinas de cualquier generación (primera: cefazolina), aunque muchas recomendaciones sugieren comenzar directamente con cefalosporinas de tercera generación (ceftriaxona) o cuarta generación (cefepime). Si alérgica, se indican aminoglicósidos (aunque son algo tóxicos para el feto) o el astreonam. Luego, se ajusta el tratamiento, según el antibiograma.

Fuente: Obstetricia, cuestionario 1.2, P4

56. Una mujer embarazada se realiza un cultivo vaginal a las 35 semanas de gestación, el que resulta positivo para Streptococcus agalactiae. La conducta más adecuada es:

a. Administrar ampicilina endovenosa durante el trabajo de parto

b. Realizar cesárea al momento del parto

c. Administrar tratamiento antibiótico erradicador, de inmediato

d. Realizar amniocentesis

e. Observar evolución, sin necesidad de ninguna medida

Respuesta correcta: a. Administrar ampicilina endovenosa durante el trabajo de parto

Explicación: Tiene el screening positivo para SGB, por lo que debe recibir profilaxis al parto con ampicilina o penicilina (eritromicina en alérgicas). - Recordar que las otras indicaciones de profilaxis son: sepsis

previa por SGB (siempre) y UCT positivo para SGB (siempre). - Si el cultivo no se ha realizado, también se indica si hay fiebre materna (ampicilina + gentamicina, para cubrir bacterias de corioamnionitis), edad gestacional menor a 37 semanas (según Minsal, esta sería una indicación independiente a si hay o no cultivo), RPM mayor a 18 horas.

Fuente: Obstetricia, cuestionario 1.2, P8

Embarazo múltiple (2)

57. Una paciente cursando un embarazo de primer trimestre, se realiza una ecografía transvaginal, que muestra un embarazo gemelar, con dos sacos gestacionales y signo de "lambda". Se puede afirmar que este embarazo tendrá mayor riesgo de todo lo siguiente, EXCEPTO:

a. Parto prematuro
b. Rotura prematura de membranas
c. Secuencia TRAP
d. Crecimiento discordante entre ambos gemelos
e. Síndrome hipertensivo del embarazo

Respuesta correcta: c. Secuencia TRAP

Explicación: Como tiene signo de Lambda, es bicorial biamniótico. La secuencia TRAP es exclusivo de los monocoriales (también la transfusión feto fetal).

Fuente: Obstetricia, cuestionario 1.1, P8

58. Una paciente embarazada acude a su primera ecografía, en la que se visualizan dos sacos gestacionales, con el signo de "lambda". Tendrá mayor riesgo de desarrollar todas las siguientes patologías, EXCEPTO:

a. Síndrome de transfusión feto-fetal
b. Parto prematuro
c. Rotura prematura de membranas
d. Preclamsia
e. Retraso del crecimiento intrauterino

Respuesta correcta: a. Síndrome de transfusión feto-fetal

Explicación: El mayor riesgo de todo embarazo gemelar es el parto prematuro. El signo de lambda demuestra que es bicorial y biamniótico. La transfusión feto fetal solo se da en los monocoriales biamnióticos.

Fuente: Obstetricia, cuestionario 1.2, P5

Restricción del crecimiento fetal (2)

59. Una mujer de 34 años presenta un embarazo de 34 semanas. Se realiza una ecografía obstétrica, que demuestra un feto con un peso en percentil 3 para la edad gestacional, con normalidad en el líquido amniótico. El registro basal no estresante no muestra alteraciones. ¿Qué conducta es más adecuada para el manejo de esta paciente?

a. Interrupción por la vía más expedita
b. Inducción del parto con misoprostol
c. Solicitar un doppler de arterias uterinas

d. Administrar corticoides y tocolíticos a la madre

e. Solicitar un doppler fetal

Respuesta correcta: e. Solicitar un doppler fetal

Explicación: Tiene un RCIU (peso menor a p10 para la edad gestacional), aunque también podría ser un PEG (desde percentil 3 en adelante puede ser PEG). - Los corticoides están indicados por tener menos de 34 semanas, pero el Doppler fetal (incluye el doppler umbilical, de arteria cerebral media y del ducto venoso) es el examen fundamental para distinguirlo del feto PEG, seguir al RCIU y determinar el momento de la interrupción, por lo que es lo más importante. - El doppler de uterinas, aunque su evidencia es muy escasa, se realiza como screening de preclamsia y de RCIU, pero en ambos casos, una vez hecho el diagnóstico, ya no tiene utilidad, por lo que el doppler fetal pasa a ser el examen más importante, para evaluar la unidad fetoplacentaria.

Fuente: Ginecología, cuestionario 2.1, P8

60. Una mujer de 34 años presenta un embarazo de 33 semanas. Se realiza una ecografía obstétrica, que demuestra un feto con un peso en percentil 5 para la edad gestacional, con el diámetro craneano mayor al diámetro abdominal y normalidad en el líquido amniótico. ¿Qué conducta es MENOS adecuada para el manejo de esta paciente?

a. Administrar corticoides a la madre

b. Solicitar PBF con frecuencia

c. Indicar actividad física frecuente, de tipo aeróbico, para mejorar el gasto cardíaco y por tanto la perfusión uterina

d. Solicitar ecografía-doppler de arterias umbilicales, con frecuencia semanal

e. Interrumpir a las 37 semanas, o en caso de mala evolución

Respuesta correcta: c. Indicar actividad física frecuente, de tipo aeróbico, para mejorar el gasto cardíaco y por tanto la perfusión uterina

Explicación: Tiene un RCIU (peso menor a p10 para la edad gestacional). No es PEG, porque es asimétrico (diámetro craneano mayor al abdominal), por lo que se interrumpirá a las 37 semanas, si todo está bien (el PEG, en cambio, se interrumpe a las 40 semanas). Los corticoides están indicados por tener menos de 34 semanas. El doppler fetal (incluye el umbilical) es el examen más importante para seguir al RCIU y se pide semanalmente (si está normal). También se pide un RBNE o un PBF cada 2 días, para evaluar el estado fetal. Finalmente, se debe indicar reposo relativo, en decúbito lateral izquierdo, para mejorar la perfusión uterina, por lo que no está indicado el ejercicio físico frecuente.

Fuente: Ginecología, cuestionario 2.2, P8

Ginecología (41)

Trastornos menstruales, amenorrea e infertilidad (6)

1. Una niña de 12 años refiere que sus reglas son muy abundantes, con coágulos en algunas ocasiones y que vienen regularmente cada 28 días, desde hace 1 año. Ha sido tratada por anemia ferropénica y se realizó una exploración clínica ginecológica, que mostró himen perforado, sin alteraciones en los genitales externos, así como una ecografía transrectal, que fue normal. ¿Qué conducta es más importante dentro de los enumerados?

a. Realizar biopsia endometrial
b. Realizar PAP y colposcopía
c. Solicitar pruebas de hemostasia
d. Realizar cultivos vaginales
e. Iniciar ACO

Respuesta correcta: c. Solicitar pruebas de hemostasia

Explicación: Tiene un sangrado uterino anormal, de tipo hipermenorrea. La causa más frecuente son los miomas submucosos, pero en las adolescentes, después de descartar alteraciones anatómicas con la ecografía, es necesario descartar las alteraciones de la hemostasia, como la enfermedad de von Willebrand.

Fuente: Ginecología, cuestionario 2.1, P18

2. Una paciente de 34 años está en amenorrea desde hace 12 meses, luego de haber dado a luz a su segundo hijo. Se realiza test de embarazo que resulta negativo, TSH: 3,0 UI/L, prolactina: normal, prueba de progesterona: negativa, prueba de estrógenos + progesterona: negativa. ¿Qué diagnóstico es más probable?

a. Síndrome de Sheehan
b. Síndrome de Asherman
c. Falla ovárica prematura
d. Anovulación
e. Amenorrea de causa hipotalámica

Respuesta correcta: b. Síndrome de Asherman

Explicación: El síndrome de Asherman tiene todo el estudio hormonal normal, porque es secundario a alteraciones uterinas: sinequias, luego del legrado postparto), por lo que tiene negativas tanto la prueba de progesterona, como la de estrógeno más progesterona. El síndrome de Sheehan (hipopituitarismo), la falla ovárica y la falla hipotalámica tienen positiva la prueba de estrógenos más progesterona. La anovulación, además, tiene positiva la prueba de progesterona.

Fuente: Ginecología, cuestionario 2.1, P19

3. Una paciente refiere que sus reglas son muy abundantes, con coágulos en algunas ocasiones y que vienen regularmente cada 28 días. ¿Qué diagnóstico es más probable dentro de los enumerados?

a. Hiperplasia endometrial
b. Cáncer de cuello uterino
c. Miomas submucosos
d. Proceso inflamatorio pélvico

e. Anovulación

Respuesta correcta: c. Miomas submucosos

Explicación: Tiene un sangrado uterino anormal, de tipo hipermenorrea. La causa más frecuente son los miomas submucosos. La HPE suele producir metrorragia, aunque también puede presentarse como hipermenorrea. El cáncer de cuello uterino produce una genitorragia, fuera del ciclo. El PIP produce leucorrea. La anovulación produce oligomenorrea.

Fuente: Ginecología, cuestionario 2.2, P18

4. Una paciente de 34 años está en amenorrea desde hace 12 meses, luego de haber dado a luz a su segundo hijo. Se realiza test de embarazo que resulta negativo, TSH: 0,2 UI/L, prolactina: 2 ng/dl, prueba de progesterona: negativa, prueba de estrógenos + progesterona: positiva, FSH: baja. ¿Qué diagnóstico es más probable?

a. Síndrome de Sheehan
b. Síndrome de Asherman
c. Falla ovárica prematura
d. Anovulación
e. Climaterio

Respuesta correcta: a. Síndrome de Sheehan

Explicación: Es una pregunta difícil. Tiene la TSH baja (lo que es compatible con un hipertiroidismo y también con un hipotiroidismo de causa central), además tiene la prolactina baja (compatible con hipopituitarismo). Sin embargo, lo más importante es que la prueba de progesterona está negativa (por lo que no es anovulación), y la prueba de estrógeno más progesterona está positiva, lo que confirma un hipogonadismo. Por tener la FSH baja, no es de causa ovárica (se descarta la FOP y el climaterio), sino que de causa central: hipotálamo-hipofisiaria. El síndrome de Sheehan es un infarto hipofisiario, por una metrorragia postparto. Se caracteriza por hipopituitarismo, con amenorrea y agalactia. En este caso, además tiene baja la prolactina y TSH. El síndrome de Asherman tiene todo el estudio hormonal normal, porque es secundario a alteraciones uterinas: sinequias postlegrado), por lo que tiene negativas tanto la prueba de progesterona, como la de estrógeno más progesterona.

Fuente: Ginecología, cuestionario 2.2, P19

5. Una mujer de 40 años está en amenorrea desde hace 5 meses. Se ha realizado varios exámenes entre los que destacan test de embarazo: negativo, TSH: normal, prolactinemia: normal, prueba de progesterona: negativa, prueba de estrógeno más progesterona: positiva y LH/FSH: disminuidas. ¿Cuál es la causa más probable de su amenorrea?

a. Anovulación
b. Alteración uterina
c. Falla ovárica primaria
d. Hipotalámica / hipofisiaria
e. Menopausia normal

Respuesta correcta: d. Hipotalámica / hipofisiaria

Explicación: Tiene la prueba de progesterona negativa, así que no puede ser anovulación. Además, tiene la prueba de estrógeno más progesterona positiva, por lo que el diagnóstico es un hipogonadismo. Finalmente, como la FSH y LH están bajas, es un hipogonadismo hipogonadotrópico, es decir, de causa

hipotalámica o hipofisiaria (recordar que “el hipo hipo es hipo hipo”). La menopausia y la falla ovárica tienen elevación de la FSH y LH.

Fuente: Ginecología, cuestionario 2.3, P3

6. Una pareja consulta porque no ha podido concebir un hijo, luego de un año de intentarlo. No utilizan ningún tipo de anticonceptivo y mantienen relaciones sexuales con regularidad, sin embargo, no han logrado ningún embarazo. Él no refiere ninguna patología previa y su examen físico es normal. Ella refiere tener reglas irregulares, que en promedio suceden cada 60 días y al examen físico se aprecia obesa, con algún grado de hirsutismo. ¿Cuál es la causa más probable de la infertilidad en esta pareja?

a. Anovulación
b. Alteraciones tubo-peritoneales
c. Endometriosis
d. Alteración del factor masculino
e. Esta pareja es normal y no tiene diagnóstico de infertilidad

Respuesta correcta: a. Anovulación

Explicación: Si bien, la causa masculina es la más frecuente en general (40%), en este caso se describe en ella un síndrome de ovario poliquístico (SOP), ya que tiene oligomenorrea e hirsutismo. Por tanto, lo más probable es que se trate de una infertilidad por anovulación, secundaria el SOP.

Fuente: Ginecología, cuestionario 2.3, P14

Miomas, adenomiosis y endometriosis (4)

7. Una paciente de 35 años, presenta hipermenorrea y dismenorrea, desde hace un año y medio. Al examen físico se palpa útero aumentado de tamaño y la ecografía transvaginal muestra un miometrio irregular. El diagnóstico más probable es:

a. Adenomiosis
b. Endometriosis
c. Miomatosis
d. Neoplasia trofoblástica gestacional
e. Cáncer de endometrio

Respuesta correcta: a. Adenomiosis

Explicación: Es una adenomiosis clásica: produce hipermenorrea y puede tener el útero grande, liso. La ecografía ve el miometrio irregular. El cáncer de endometrio se presenta como metrorragia con útero aumentado. La ecografía muestra al endometrio engrosado e irregular. La endometriosis produce solo dismenorrea e infertilidad, sin alteraciones en el flujo rojo. La ecografía suele ser normal. Los miomas producen hipermenorrea y un útero nodular. La ecografía los ve como un tumor sólido, homogéneo e hiperecogénico.

Fuente: Ginecología, cuestionario 2.1, P11

8. ¿Cuál de las siguientes opciones es más probable de encontrar en una paciente con endometriosis?

a. Metrorragia
b. Dispareunia superficial
c. Infertilidad
d. Dismenorrea primaria

e. Leucorrea

Respuesta correcta: c. Infertilidad

Explicación: La endometriosis presenta dolor (dismenorrea secundaria, dispareunia profunda y disquexia), más infertilidad. No tiene alteraciones de los flujos rojos ni blancos. Como todo proceso peritoneal, puede elevar el Ca-125.

Fuente: Ginecología, cuestionario 2.1, P16

9. ¿Cuál de las siguientes opciones es MENOS probable de encontrar en una paciente con endometriosis?

a. Infertilidad
b. Dispareunia profunda
c. Hipermenorrea
d. Elevación del Ca-125
e. Algia pélvica crónica cíclica

Respuesta correcta: c. Hipermenorrea

Explicación: La endometriosis presenta dolor (dismenorrea secundaria, dispareunia profunda y disquexia), más infertilidad. No tiene alteraciones de los flujos rojos ni blancos. Como todo proceso peritoneal, puede elevar el Ca-125.

Fuente: Ginecología, cuestionario 2.2, P16

10. Una mujer de 28 años presenta dismenorrea desde hace un año, que cada vez es más intensa. Al examen físico se constata dolor a la movilización cervical, la que es difícil de realizar. Su ecografía transvaginal es normal. ¿Cuál de los siguientes diagnósticos es compatible con el cuadro descrito?

a. Proceso inflamatorio pélvico
b. Adenomiosis
c. Hiperplasia endometrial
d. Endometriosis
e. Dismenorrea primaria

Respuesta correcta: d. Endometriosis

Explicación: Es una endometriosis clásica: dismenorrea secundaria (la primaria inicia con la menarquia), progresiva y además tiene dificultad y dolor para mover el cuello, dado que se formad adherencias. La ecografía suele estar normal, por lo que se debe estudiar con laparoscopía (La ecografía solo está alterada en los endometriomas). El PIP es un cuadro agudo, de dolor, leucorrea y fiebre. La denomiosis tiene hipermenorrea y dismenorrea y la ecografía tiene miometrio irregular. La hiperplasia endometrial tiene metrorragia y la ecografía suele mostrar engrosamiento del endometrio.

Fuente: Ginecología, cuestionario 2.3, P11

Patología cervical, PAP y virus papiloma (7)

11. Una paciente de 40 años se realiza una especuloscopía que resulta normal, tomándose un PAP que es informado como muestra satisfactoria, con presencia de células displásicas de alto grado. La conducta más adecuada es:

a. Repetir el PAP en un año
b. Repetir el PAP inmediatamente
c. Realizar cono cervical

d. Repetir el PAP en 3 meses
e. Derivar a patología cervical, para realización de colposcopía y biopsia de la lesión

Respuesta correcta: e. Derivar a patología cervical, para realización de colposcopía y biopsia de la lesión

Explicación: Por regla general, todo PAP con atipias debe derivarse a colposcopía y biopsia, para confirmar el diagnóstico. Esto se verá con detalle en ginecología.

Fuente: Hematología, prueba 4 del 8 de mayo de 2024, P6

12. Una paciente de 40 años se realiza una especuloscopía que resulta normal, tomándose un PAP que es informado como muestra satisfactoria, con presencia de células displásicas de alto grado. La conducta más adecuada es:

a. Derivar a patología cervical, para realización de colposcopía y biopsia de la lesión
b. Repetir el PAP en un año
c. Realizar cono cervical
d. Repetir el PAP inmediatamente
e. Repetir el PAP en 3 meses

Respuesta correcta: a. Derivar a patología cervical, para realización de colposcopía y biopsia de la lesión

Explicación: Por regla general, todo PAP con atipias debe derivarse a colposcopía y biopsia, para confirmar el diagnóstico. Esto se verá con profundidad en Ginecología, ya que existen muchos detalles importantes a conocer. Eso sí, esto es lo principal: PAP alterado = colposcopía y biopsia.

Fuente: Hematología, prueba 7 del 8 de mayo de 2024, P20

13. Una mujer se realiza un PAP que es informado con presencia de atipías de tipo glandular, de grado moderado. La conducta más adecuada es:

a. Realizar legrado endometrial biópsico
b. Realizar cono cervical
c. Solicitar nuevo PAP en un año
d. Realizar colposcopía y curetaje endocervical
e. Realizar histerectomía

Respuesta correcta: d. Realizar colposcopía y curetaje endocervical

Explicación: Las atipías galndulares, se derivan a colposcopía, más curetaje endocervical y biopsia. Si está normal, se prosigue el estudio con una biopsia de endometrio. Las AGUS se manejan igual.

Fuente: Ginecología, cuestionario 2.1, P17

14. Una mujer se realiza un PAP que es informado con presencia de atipías de tipo escamoso, de grado moderado. La conducta más adecuada es:

a. Realizar legrado endometrial biópsico
b. Realizar cono cervical
c. Solicitar nuevo PAP en un año
d. Realizar colposcopía
e. Realizar histerectomía

Respuesta correcta: d. Realizar colposcopía

Explicación: Las atipías escamosas, se derivan a colposcopía y biopsia. La excepción son las ASCUS, que pueden seguirse con PAP en 6 meses, o tipificar el VPH, o bien derivarlas a colposcopía y biopsia.

Fuente: Ginecología, cuestionario 2.2, P17

15. Una mujer se realiza un Papanicolaou de control, que muestra células atípicas de tipo glandular. La conducta más adecuada es:

a. Observar evolución
b. Repetir el Papanicolaou
c. Realizar colposcopía y curetaje endocervical
d. Realizar biopsia endometrial Pipelle
e. Realizar cono biópsico

Respuesta correcta: c. Realizar colposcopía y curetaje endocervical

Explicación: Las atipías glandulares se estudian con colposcopía y curetaje endocervical, más la biopsia. En cambio, las atipías escamosas se estudian con colposcopía y biosia y el curetaje endocervical solo se hace si es que la colposcocpía es insatisfactoria (la zona de transición se mete en el orificio cervical externo. El cono biópsico se solicita en la disociación colpocitológica (PAP atípico escamoso, de alto grado, con colposcopía normal). El cono terapéutico, en cambio, se indica en la NIE 2 y 3 y en el carcinoma in situ. La biopsia Pipelle se realiza como parte del estudio de la metrorragia, cuando se quiere descartar un cáncer de endometrio (después del test de embarazo y la ecoTV).

Fuente: Ginecología, cuestionario 2.3, P5

16. Una mujer consulta por lesiones vulvares indoloras. Al examen se aprecian varias lesiones solevantadas, polipoideas en relación a los labios mayores y menores. El agente etiológico más probable es:

a. Virus Herpes simplex
b. Virus papiloma humano
c. Virus pox
d. Chlamydia trachomatis
e. Treponema pallidum

Respuesta correcta: b. Virus papiloma humano

Explicación: Son condilomas acuminados clásicos, causados por VPH. Vale la pena mencionar que el virus pox es causa del molusco contagioso, que, en adultos, también se considera una infección de transmisión sexual, al igual que la viruela del mono (monkey pox o m-pox), que es de la misma familia: poxviridae.

Fuente: Ginecología, cuestionario 2.3, P15

17. Una paciente se realiza un PAP que muestra células escamosas y glandulares normales, con muestra satisfactoria. Su especuloscopía muestra una lesión cervical solevantada, de un centímetro de diámetro. La conducta más adecuada

a. Observar evolución
b. Realizar cono biópsico
c. Realizar colposcopía y biopsia
d. Realizar curetaje endocervical
e. Realizar histerectomía

Respuesta correcta: c. Realizar colposcopía y biopsia

Explicación: Tanto la visualización de un tumor cervical, como el PAP atípico son indicación de colposcopía y biopsia. El cono biópsico se indica en la disociación colpocitológica (atipías escamosas de alto grado, con

colposcopía normal). El curetaje endocervical se indica en las atipías glandulares y en las atipías escamosas, con colposcopía insatisfactioria.

Fuente: Ginecología, cuestionario 2.3, P19

Hiperplasia y cáncer de endometrio (3)

18. Una paciente con antecedente de SOP, presenta metrorragia en 2 oportunidades. Al examen físico se palpa útero aumentado de tamaño y la ecografía transvaginal muestra un endometrio engrosado, irregular. El diagnóstico más probable es:

a. Adenomiosis
b. Endometriosis
c. Miomatosis
d. Neoplasia trofoblástica gestacional
e. Cáncer de endometrio

Respuesta correcta: e. Cáncer de endometrio

Explicación: Tanto por el antecedente de SOP (anovulación), como por la clínica: metrorragia con útero aumentado y alteración ecográfica del endometrio, es un cáncer de endometrio. La adenomiosis produce hipermenorrea y sí puede tener el útero grande. La ecografía ve el miometrio irregular. La endometriosis produce solo dismenorrea e infertilidad, sin alteraciones en el flujo rojo. La ecografía suele ser normal. Los miomas producen hipermenorrea y un útero nodular. La ecografía los ve como un tumor sólido, homogéneo e hiperecogénico.

Fuente: Ginecología, cuestionario 2.2, P11

19. Una mujer de 50 años, diabética, en tratamiento con metformina y glibenclamida, consulta por metrorragia de una semana de evolución. Refiere que sus reglas son irregulares, sucediendo cada 2 a 3 meses y durando entre 3 y 5 días y que su última regla fue hace sólo 14 días. Al examen físico se aprecia una mujer obesa, con genitales externos normales y útero aumentado de tamaño. El test de embarazo es negativo y se solicita una ecografía transvaginal, que muestra un endometrio de 20 mm de diámetro, de aspecto irregular y zonas del miometrio heterogéneas. El diagnóstico más probable es:

a. Cáncer de endometrio
b. Miomatosis uterina
c. Adenomiosis
d. Endometriosis
e. Hiperplasia endometrial

Respuesta correcta: a. Cáncer de endometrio

Explicación: Tiene algunos factores de riesgo del cáncer de endometrio (HONDA: HTA, Obesidad, nuliparidad, Diabetes y Anovulación), pero también son factores de riesgo para la hiperplasia endometrial (HPE). Tanto HPE, como el cáncer de endometrio tienen metrorragia y endometrio grueso. Sin embargo, la afectación del miometrio solo se ve en el cáncer. La miomatosis produce hipermenorrea y se habría visto en la ecografía, como tumores redondos, homogéneos e hipoecogénicos. La adenomiosis tiene dismenorrea e hipermenorrea (no metrorragia) y sí se ve con afectación del miometrio, pero sin engrosamiento del endometrio. La endometriosis solo presenta dolor e infertilidad, sin metrorragia.

Fuente: Ginecología, cuestionario 2.3, P4

20. Una mujer de 56 años se realiza una biopsia endometrial, que demuestra presencia de hiperplasia endometrial simple, sin atipias. La conducta más adecuada es:

a. Indicar estrógenos locales
b. Indicar progestágenos
c. Solicitar niveles plasmáticos de beta-HCG
d. Realizar legrado uterino
e. Realizar histerectomía total

Respuesta correcta: b. Indicar progestágenos

Explicación: La hiperplasia endometrial simple se trata con progestágenos orales, o con el DIU medicado con levonorgestrel (un tipo de progestágeno). La hiperplasia endometrial atípica y la compleja, se tratan con histerectomía.

Fuente: Ginecología, cuestionario 2.3, P8

Tumores anexiales y cáncer de ovario (4)

21. En un control, una mujer de 60 años se realiza una ecografía transvaginal, que muestra la presencia de un tumor anexial derecho de 5 cm de diámetro, de aspecto quístico, con presencia de varias increcencias. La conducta más adecuada es:

a. Iniciar tratamiento con agonistas de GnRH y realizar tumorectomía laparoscópica en 3 meses
b. Iniciar anticonceptivos orales y controlar con nueva ecografía en 3 meses
c. Observar evolución
d. Realizar drenaje por punción del contenido del tumor quístico
e. Realizar anexectomía y biopsia quirúrgica

Respuesta correcta: e. Realizar anexectomía y biopsia quirúrgica

Explicación: Tiene tumor anexial complejo, por lo que debe sospecharse un cáncer de ovario. Por tanto, se debe proceder a la cirugía laparocópica, con biosia rápida intraoperatoria. Por ser postmenopáusica, no vale la pena hacer una tumorectomía, sino directamente la anexectomía. Las biopsias ováricas no son por punción, sino quirúrgicas.

Fuente: Ginecología, cuestionario 2.1, P12

22. En un control, una mujer de 60 años se realiza una ecografía transvaginal, que muestra la presencia de un tumor anexial derecho de 7 cm de diámetro, de aspecto quístico, con presencia de varias increcencias y escasa ascitis. El diagnóstico más probable es:

a. Endometrioma
b. Quiste folicular
c. Cuerpo albicans
d. Teratoma quístico
e. Cistoadenocarcinoma

Respuesta correcta: e. Cistoadenocarcinoma

Explicación: Es un cáncer de ovario clásico: tumor anexial complejo y con ascitis, en una mujer postmenopáusica. El cistoadenocarcinoma es el más frecuente. El endometrioma ocurre en mujeres en edad fértil y tiene dolor y aspecto quístico, en vidrio esmerilado. El quiste folicular ocurre en mujeres en

edad fértil y tiene aspecto quístico simple. El cuerpo albicans es una cicatriz de un cuerpo lúteo que involucionó. Generalmente no se ve en la ecografía y es algo normal.

Fuente: Ginecología, cuestionario 2.2, P12

23. Una mujer de 56 años de edad, menopáusica hace 4 años, acude a control ginecológico, donde se constata la palpación de un tumor anexial de cerca de 6 cm de diámetro. A la ecografía transvaginal se constata de aspecto sólido quístico, con tabiques y excrescencias. La conducta más adecuada es:

a. Observar evolución
b. Iniciar terapia de reemplazo hormonal y controlar con nueva ecografía en 3 meses
c. Indicar agonistas de la GnRH y controlar con nueva ecografía en 3 meses
d. Realizar biopsia por punción con aguja fina
e. Resolver quirúrgicamente, con anexectomía y biopsia rápida intraoperatoria

Respuesta correcta: e. Resolver quirúrgicamente, con anexectomía y biopsia rápida intraoperatoria

Explicación: Tiene un tumor anexial complejo (sospechoso de cáncer). Por tanto, se debe operar y se debe realizar la biopsia rápida intraoperatoria. Se realiza una anexectomía por ser postmenopáusica. Si la biopsia demuestra un cáncer de ovario, se procede a la anexectomía bilateral, con histerectomía y toma de biopsias peritoneales y luego se realiza una quimioterapia.

Fuente: Ginecología, cuestionario 2.3, P6

24. Una mujer de 35 años acude al ginecólogo a control, se realiza un tacto vaginal, que demuestra un tumor anexial derecho. Se solicita ecografía, que muestra una lesión quística de 4 cm, de contenido anecogénico, en el ovario derecho. Su Ca125 resulta 12 UI/L. El diagnóstico más probable es:

a. Cuerpo lúteo
b. Teratoma
c. Cáncer de ovario
d. Quiste folicular
e. Endometrioma

Respuesta correcta: d. Quiste folicular

Explicación: Es un quiste folicular clásico: lesión quística simple, anecogénica, en una mujer en edad fértil. El Ca125 está normal (menor a 35 UI/L). Se observa. - El cuerpo lúteo es sólido-quístico. - El teratoma benigno suele ser sólido y muy heterogéneo, o bien sólido-quístico, con visualización de dientes en su interior. - El cáncer de ovario suele presentarse en mujeres postmenopáusicas y tiene un aspecto sólido-quístico, con elevación del Ca125. - El endometrioma produce dismenorrea y además suele elevar el Ca125. Eso sí, tiene aspecto quístico, pero con contenido hipoecogénico (en vidrio esmerilado).

Fuente: Ginecología, cuestionario 2.3, P20

Patología mamaria (3)

25. Una mujer de 50 años se realiza una mamografía que muestra una lesión espiculada y densa, con algunas calcificaciones, informada como Birrads 4. La conducta más adecuada es:

a. Solicitar ecografía mamaria
b. Solicitar nueva mamografía de inmediato
c. Controlar con nueva mamografía en 6 meses
d. Derivar para biopsia mamaria con mamótomo

e. Derivar para resolución quirúrgica inmediata

Respuesta correcta: d. Derivar para biopsia mamaria con mamótomo

Explicación: Birrads 0 (mamografía no sirve) = ecografía. Birrads 1 (normal) = mamografía en 1 o 2 años. Birrads 2 (benigno) = mamografía en 1 o 2 años. Birrads 3 (lesión incierta) = mamografía en 6 meses y se puede complementar con ecografía. Birrads 4 (lesión sospechosa de cáncer) = biopsia por punción (mamótomo, trucut, punción con aguja gruesa; estereotáxica si no es palpable). Birrads 5 (cáncer con alta probabilidad) = biopsia quirúrgica. Birrads 6 (cáncer ya diagnosticado previamente, con biopsia) = tratamiento del cáncer, según estadía.

Fuente: Ginecología, cuestionario 2.1, P15

26. Una mujer de 50 años se realiza una mamografía que muestra una lesión densa, informada como Birrads 0. La conducta más adecuada es:

a. Solicitar ecografía mamaria
b. Solicitar nueva mamografía de inmediato
c. Controlar con nueva mamografía en 12 meses
d. Derivar para biopsia mamaria con mamótomo
e. Derivar para resolución quirúrgica inmediata

Respuesta correcta: a. Solicitar ecografía mamaria

Explicación: Birrads 0 (mamografía no sirve) = ecografía. Birrads 1 (normal) = mamografía en 1 o 2 años. Birrads 2 (benigno) = mamografía en 1 o 2 años. Birrads 3 (lesión incierta) = mamografía en 6 meses y se puede complementar con ecografía. Birrads 4 (probable cáncer) = biopsia por punción (mamótomo, trucut, estereotáxica, etc). Birrads 5 (cáncer) = biopsia quirúrgica. Birrads 6 (cáncer ya diagnosticada con biopsia) = tratamiento del cáncer, según estadía.

Fuente: Ginecología, cuestionario 2.2, P15

27. Una mujer de 59 años, asintomática, se realiza una mamografía, que muestra la presencia de un nódulo mamario derecho de 3 cm de diámetro, denso y de bordes irregulares, con múltiples calcificaciones pequeñas agrupadas. El diagnóstico más probable es:

a. Fibroadenoma
b. Carcinoma ductal
c. Carcinoma lobulillar in situ
d. Mastopatía fibroquística
e. Enfermedad de Paget

Respuesta correcta: b. Carcinoma ductal

Explicación: La imagen descrita es de cáncer de mama (denso, irregular y con microcalcificaciones). El cáncer ductal invasor es el más frecuente. Vale la pena recordar que el cáncer lobulillar in situ no progresa a cáncer invasor, por lo que se considera una lesión benigna (en cambio, el cáncer ductal in situ sí progresa).

Fuente: Ginecología, cuestionario 2.3, P2

Infecciones ginecológicas (6)

28. Una mujer de 30 años consulta por leucorrea, abundante y disuria. Al examen físico se aprecia mucosa vulvar y vaginal eritematosa, con cuello uterino con abundantes petequias y leucorrea verde abundante. Además, presenta mal olor. La etiología más probable del cuadro descrito es:

a. Parasitaria
b. Bacteriana
c. Obstrucción al tracto genital
d. Tumoral
e. Funcional

Respuesta correcta: a. Parasitaria

Explicación: Tiene una tricomoniasis clásica, que es un parásito (protozoo flagelado).

Fuente: Ginecología, cuestionario 2.1, P14

29. Una mujer de 30 años consulta por leucorrea y dolor abdominal bajo. Al examen físico se aprecia mucosa vulvar y vaginal normales, con escasa leucorrea que proviene del OCE. Además, presenta dolor a la palpación anexial y a la movilización cervical. La etiología más probable del cuadro descrito es:

a. Parasitaria
b. Bacteriana
c. Obstrucción al tracto genital
d. Tumoral
e. Funcional

Respuesta correcta: b. Bacteriana

Explicación: Tiene un PIP clásico, que es causado por gonococo o Chlamydia trachomatis y luego se sobreinfecta con otras bacterias, en especial Gram negativos y anaerobios.

Fuente: Ginecología, cuestionario 2.2, P14

30. Una mujer de 30 años, consulta por dolor abdominal bajo, asociado a fiebre hasta 38,8°C. Como antecedente refiere que su última regla fue hace 7 días y que mantiene actividad sexual con cierta frecuencia, aunque no tiene pareja estable. El tacto vaginal demuestra dolor al mover el cuello uterino y a la palpación anexial izquierda. El diagnóstico más probable es:

a. Embarazo ectópico
b. Endometriosis
c. Infección intraamniótica
d. Apendicitis
e. Proceso inflamatorio pélvico

Respuesta correcta: e. Proceso inflamatorio pélvico

Explicación: Es un PIP clásico: Fiebre, leucorrea y dolor (a la palpación hipogástrica, movilización cervical y palpación anexial). El embarazo ectópico tiene metrorragia y shock hipovolémico. No está embarazada, porque su última regla fue hace 7 días. La endometriosis tiene un cuadro crónico de infertilidad y dolor (dismenorrea, dispareunia y disquexia). También puede tener dificultad en la movilización cervical, pero es crónico. La infección intramniótica es asintomática, a diferencia de la corioamnionitis, que tiene la misma clínica de PIP, pero en el embarazo.

Fuente: Ginecología, cuestionario 2.3, P1

31. Una mujer consulta por leucorrea de cerca de 15 días de evolución, caracterizada por leucorrea abundante, amarillenta y espumosa, de mal olor, asociada a ardor y prurito vulvar. El diagnóstico más probable es:

a. Tricomoniasis
b. Vaginosis
c. Candidiasis
d. Gonorrea
e. Vulvovaginitis inespecífica

Respuesta correcta: a. Tricomoniasis

Explicación: Es una tricomoniasis clásica: leucorrea espumosa verde-amarillenta, ardor y prurito, con marcada inflamación. Además, suele tener mal olor, a podrido. La vaginosis tiene leucorrea blanca grisácea, con mal olor, a pescado, sin signos inflamatorios. Puede ser algo espumosa. La candidiasis tiene leucorrea blanca grumosa, con prurito. La gonorrea suele producir uretritis, PIP y cervicitis, pero no vulvovaginitis. En el PIP la leucorrea proviene de la cavidad endometrial, por lo que se ve salir del OCE. En la cervicitis proviene del cuello. La vulvovaginitis inespecífica afecta a niñas y tiene una clínica inespecífica de leucorrea blanca o amarillenta, con inflamación.

Fuente: Ginecología, cuestionario 2.3, P7

32. Una niña de 5 años presenta metrorragia de mal olor. Al examen físico se aprecia secreción hemopurulenta que proviene de la vagina. El diagnóstico más probable es:

a. Himen imperforado complicado
b. Abuso sexual
c. Vulvovaginitis inespecífica
d. Cuerpo extraño vaginal
e. Cáncer de vagina

Respuesta correcta: d. Cuerpo extraño vaginal

Explicación: Es un cuerpo extraño vaginal clásico: metrorragia y leucorrea de mal olor. Lo más frecuente es que se trate de papel higiénico sobre el himen. Se debe hacer una vaginoscopía y retirarlo. El himen imperforado suele diagnosticarse al nacer (con un buen examen físico), siendo asintomático. O bien, se diagnostica en la pubertad, como causa de amenorrea primaria, más dolor abdominal, que aumenta con el ciclo hormonal y además se puede palpar el útero grande. Se diagnostica con la inspección y se trata con cirugía menor. El abuso sexual sí puede tener la misma clínica del cuerpo extraño, pero además suele tener erosiones vulvovaginales, signos de maltrato, conducta sexualizada, etc. La vulvovaginitis inespecífica tiene leucorrea inespecífica, con signos inflamatorios inespecíficos. El cáncer de vagina afecta a adultas y se presenta como un cuadro crónico de prurito vaginal, seguido luego de genitorragia y adenopatías inguinales.

Fuente: Ginecología, cuestionario 2.3, P12

33. El tratamiento de elección de la tricomoniasis vaginal es:

a. Clindamicina tópica
b. Fluconazol oral
c. Albendazol oral
d. Doxiciclina oral

e. Metronidazol oral

Respuesta correcta: e. Metronidazol oral

Explicación: La tricomoniasis se trata idealmente con metronidazol o tinidazol, en monodosis (MTZ 2 gramos, VO, por 1 vez). La clindamicina tópica sirve para la vaginosis en pacientes embarazadas o alérgicas al metronidazol. El fluconazol es el tratamiento de la candidiasis. El albendazol es el tratamiento de las infecciones por nemátodos (Ascaris, triquinosis, larva migrante, pidulles, etc.).

Fuente: Ginecología, cuestionario 2.3, P16

Anticoncepción (4)

34. ¿Cuál de las siguientes es una contraindicación del uso de ACO?

a. Antecedentes familiares de cáncer de endometrio
b. Antecedentes familiares de cáncer de ovario
c. Antecedentes familiares de cáncer de cuello uterino
d. Hipertensión arterial
e. Trombofilia

Respuesta correcta: e. Trombofilia

Explicación: Las contraindicaciones más importantes de los ACO son: antecedente personal de cáncer de mama, cáncer de endometrio, metrorragia de origen desconocido (porque puede ser de endometrio), los melanomas, el alto riesgo cardiovascular (ej. fumadora mayor de 35 años), las trombofilias, el lupus, la migraña que empeora con ACO. Vale la pena mencionar que los antecedentes familiares no contraindican el uso de ACO.

Fuente: Ginecología, cuestionario 2.1, P13

35. ¿Cuál de las siguientes es una contraindicación del uso de ACO?

a. Antecedentes familiares de cáncer de endometrio
b. Antecedentes familiares de cáncer de ovario
c. Antecedentes familiares de cáncer de mama
d. Jaqueca con aura
e. Síndrome de ovario poliquístico

Respuesta correcta: d. Jaqueca con aura

Explicación: Los ACO aumentan el riesgo de cáncer de mama y disminuyen el riesgo de cáncer de ovario y de endometrio. Los antecedentes familiares de ellos, no tienen mayor importancia y no contraindican el uso de ACO. Eso sí, el antecedente personal de cáncer de mama o de cáncer de endometrio, sí contraindican absolutamente el uso de ACO. Por su parte el SOP se trata con ACO. La jaqueca con aura es una contraindicación relativa de los ACO, en especial si es que la jaqueca empezó con el uso de los mismos o si empeora con ellos.

Fuente: Ginecología, cuestionario 2.2, P13

36. ¿Cuál es el efecto adverso más frecuente de los anticonceptivos con microdosis de etinil estradiol?

a. Atrofia genitourinaria
b. Dislipidemia
c. Trombosis venosa profunda
d. Spotting (goteo)

e. Síntomas vasomotores (bochornos)

Respuesta correcta: d. Spotting (goteo)

Explicación: El efecto adverso más frecuente de la microdosis de estrógeno es el goteo intermenstrual o spotting. Lo beneficioso es que tienen menos efectos adversos. Por ello, habitualmente se inicia una microdosis (15 a 20 ug) y solo si tiene spotting, se sube a la dosis estándar de etinilestradiol (30 ug).

Fuente: Ginecología, cuestionario 2.3, P10

37. ¿Cuál de las siguientes es una contraindicación del uso de dispositivo intrauterino, como método anticonceptivo?

a. Multípara
b. Cesárea previa
c. Antecedente familiar de cáncer de endometrio
d. Promiscuidad sexual
e. Antecedente de abortos previos

Respuesta correcta: d. Promiscuidad sexual

Explicación: La promiscuidad sexual tiene riesgo de proceso infamatorio pélvico (PIP), por lo que se debe evitar el DIU, que también aumenta el riesgo de PIP (al insertarlo y retirarlo, por algunos días), pero que, además, en caso de un PIP es posible que haya que retirarlo. Actualmente, la recomendación en un PIP, más DIU, es indicar tratamiento antibiótico y evaluar en 2 a 3 días. Si responde por completo, se puede mantener el DIU. Si no responde, es obligatorio retirarlo.

Fuente: Ginecología, cuestionario 2.3, P17

Climaterio y menopausia (2)

38. Una mujer de 50 años, sin antecedentes de importancia, consulta por bochornos y sequedad vaginal. No presenta otros síntomas y su examen físico es normal. La conducta más adecuada es:

a. Indicar raloxifeno
b. Indicar progestágeno sólo
c. Indicar estrógeno solo
d. Indicar estrógeno + progestágeno
e. Indicar agonistas de la GnRH

Respuesta correcta: d. Indicar estrógeno + progestágeno

Explicación: Tiene indicación de TRH, por los bochornos. Como tiene útero, se indican estrógenos más progestágenos. Si hubiese estado histerectomizada, solo se indicarían los estrógenos solos. Los progestágenos solos, se indican como anticonceptivo, en la lactancia materna.

Fuente: Ginecología, cuestionario 2.1, P20

39. Una mujer de 50 años, histerectomizada, por acretismo placentario, consulta por bochornos y sequedad vaginal. No presenta otros síntomas y su examen físico es normal. La conducta más adecuada es:

a. Indicar raloxifeno
b. Indicar progestágeno sólo
c. Indicar estrógeno solo
d. Indicar estrógeno + progestágeno

e. Indicar agonistas de la GnRH

Respuesta correcta: c. Indicar estrógeno solo

Explicación: Tiene indicación de TRH, por los bochornos. Además, por ser histerectomizada, solo se indican los estrógenos solos. Si hubiese tenido útero, se indicaría el estrógeno más progestágeno. Los progestágenos solos, se indican como anticonceptivo, en la lactancia materna.

Fuente: Ginecología, cuestionario 2.2, P20

Piso pélvico e incontinencia urinaria (2)

40. ¿Cuál es el punto anatómico que se utiliza como referencia para determinar el grado de prolapso genital?

a. El orificio cervical externo
b. El fórnix anterior
c. El fórnix posterior
d. El introito
e. El clítoris

Respuesta correcta: d. El introito

Explicación: El introito es el plano en el que estaba el himen. Se usa como punto de referencia para el estudio del prolapso.

Fuente: Ginecología, cuestionario 2.3, P9

41. Una paciente de 68 años consulta por pequeños escapes de orina, que se producen con frecuencia, al realizar fuerza, al toser o al reírse. Ha realizado ejercicios de Kegel, sin respuesta y su urocultivo es normal. La conducta más adecuada es:

a. Iniciar estrógenos locales
b. Iniciar estrógenos más progestágenos orales
c. Solicitar cistoscopía
d. Iniciar anticolinérgicos orales
e. Resolver quirúrgicamente

Respuesta correcta: e. Resolver quirúrgicamente

Explicación: El tratamiento de la incontinencia urinaria de esfuerzos consiste en la kinesioterapia pélvica (ejercicios de Kegel) y si no responden, se procede a la cirugía, con una TVT o TOT (cinta transvaginal o cinta transobturatriz). La incontinencia de urgencia, en cambio, se trata con psicoterapia cognitivo conductual (entrenamiento vesical), seguido de anticolinérgicos (idealmente tolterodina, o en su defecto, la oxibutinina). En ambos casos, antes, es necesario descartar ITU, con el urocultivo.

Fuente: Ginecología, cuestionario 2.3, P18

Salud pública (60)

Tipos de estudio y diseño epidemiológico (8)

1. ¿Qué tipo estudio es el más adecuado para determinar el desarrollo de depresión en un grupo de trabajadores, a lo largo de un determinado tiempo?

a. Estudio de prevalencia
b. Estudio de incidencia
c. Estudio de caso control
d. Estudio de cohortes
e. Ensayo clínico controlado

Respuesta correcta: b. Estudio de incidencia

Explicación: Es una pregunta muy difícil, pero que apareció en el Eunacom. Se mide la incidencia de depresión, por lo que sería un estudio de incidencia. Sin embargo, también se lo llama estudio de cohorte, ya que se sigue en el tiempo al grupo de sujetos observados, para determinar la aparición de la enfermedad. Sin embargo, algunos hacen la diferencia entre estudio de incidencia, que es un estudio descriptivo, que simplemente mide la incidencia, versus el estudio de cohortes, que es un estudio analítico, que, además, busca una relación causal con un factor de riesgo.

Fuente: Salud pública, cuestionario 2.1, P7

2. ¿Cuál es el mejor diseño de estudio epidemiológico que entrega evidencia de mayor calidad, para buscar la asociación entre una exposición y una enfermedad muy infrecuente en una población?

a. Estudio de serie de casos
b. Estudio de series temporales
c. Estudio de casos y controles
d. Estudio de cohorte
e. Estudio clínico no randomizado

Respuesta correcta: c. Estudio de casos y controles

Explicación: Dado que es una enfermedad infrecuente, debe usarse casos y controles.

Fuente: Salud pública, cuestionario 2.1, P12

3. En Quintero, una ciudad chilena, se produjo una fuga de químicos desde una empresa, lo que generó una nube tóxica, que afectó a gran parte de la población. La autoridad sanitaria controló a los niños de 7 colegios de esa ciudad, de manera de determinar la frecuencia de infecciones respiratorias y otras patologías respiratorias y los comparó con los niños de los colegios de las comunas cercanas, que no fueron afectadas por la nube tóxica. ¿A qué tipo de estudio corresponde?

a. Ecológico
b. Cohortes
c. Caso control
d. Cuasiexperimental
e. Experimental

Respuesta correcta: b. Cohortes

Explicación: Es un clásico estudio de cohortes: se eligen a dos grupos (expuestos y no expuestos a un factor de riesgo) y se siguen en el tiempo para ver si enferman. Ecológico sería comparar niveles ambientales de contaminantes en distintas ciudades y comparar las tasas de incidencia de patología respiratoria de dichas ciudades. Caso control sería comparar pacientes con patología respiratoria (casos) con pacientes sanos (controles) y preguntar por exposición a contaminantes, en el pasado. Cuasiexperimental sería exponer a un grupo de animales (antiético en humanos) a contaminantes y ver la frecuencia de patología respiratoria, pero sin contar con un grupo control. Experimental sería igual, pero con grupo control.

Fuente: Salud pública, cuestionario 2.2, P5

4. ¿Qué tipo de estudio es el indicado para determinar las necesidades de financiamiento para un programa de salud, enfocado en el manejo de los factores de riesgo cardiovascular (programa cardiovascular)?

a. Estudio de cohortes
b. Estudio de incidencia
c. Estudio de casos y controles
d. Estudio experimental
e. Estudio de prevalencia

Respuesta correcta: e. Estudio de prevalencia

Explicación: La cantidad de recursos a financiar depende de la cantidad de pacientes enfermos, es decir, de la prevalencia. Más aun si se trata de enfermedades crónicas.

Fuente: Salud pública, cuestionario 2.2, P7

5. Se realiza un estudio que muestra que en Santiago la prevalencia de depresión es más alta que en las regiones de Chile y se analizan los factores de riesgo que pueden explicar estas diferencias. ¿Qué tipo de estudio es?:

a. Ecológico
b. Ensayo clínico
c. Analítico
d. De intervención comunitaria
e. De cohortes

Respuesta correcta: c. Analítico

Explicación: Las relaciones de causalidad (como la que hay entre un factor de riesgo y la patología determinada por dicho factor de riesgo), se estudian con la epidemiología analítica. En específico, pareciera ser un estudio de prevalencia, de tipo analítico. No hay información para afirmar que sea ecológico. No existe intervención, por lo que no es ni ensayo clínico, ni un estudio de intervención comunitaria (ambos son experimentales). No puede ser de cohortes, ya que estos son prospectivos y utilizan la incidencia, no la prevalencia.

Fuente: Salud pública, cuestionario 2.3, P1

6. ¿Cuál de los siguientes corresponde a un estudio descriptivo?

a. Se comparan dos fármacos para el tratamiento de la leucemia linfática crónica
b. Se calcula la prevalencia de obesidad, diabetes, dislipidemia, hipertensión y tabaquismo en una población

c. Se tienen 28 pacientes con cáncer de laringe y 40 pacientes sanos y se calcula el número de cigarrillos que fumaron durante su vida

d. Se seleccionan a 600 estudiantes usuarios de drogas y 1200 pacientes que no consumen y se los sigue por 5 años, determinando su rendimiento académico y tasas de deserción escolar

e. Se administra un nuevo fármaco a pacientes con jaqueca y se ve si mejoran, sin contar con un grupo de control

Respuesta correcta: b. Se calcula la prevalencia de obesidad, diabetes, dislipidemia, hipertensión y tabaquismo en una población

Explicación: Las determinación de frecuencias, como las tasas de prevalencia o de incidencia de una patología, son parte de la epidemiología descriptiva. En cambio, cuando se buscan relaciones de causalidad, pasa a ser epidemiología analítica. La opción A es un ensayo clínico, por lo que es analítico y además, experimental. La opción B es un estudio de prevalencia y no muestra relaciones de causa efecto, por lo que es descriptivo. La opción C es un estudio de casos y controles, observacional, restrospectivo, pero analítico, dado que busca una relación de causa-efecto. La opción D es un estudio de cohortes, observacional, prospectivo, pero también analítico, por determinar relaciones de causa-efecto. La opción E es un estudio cuasiexperimental (intervención, sin grupo de control), que es un estudio de tipo analítico, ya que intenta determinar relaciones de causa- efecto (busca los efectos de la intervención).

Fuente: Salud pública, cuestionario 2.3, P2

7. ¿Qué tipo de estudio es el que entrega una mejor información para determinar la relación de causalidad entre un factor de riesgo y una patología muy rara, en una determinada población?

a. Estudio de caso control

b. Estudio ecológico

c. Estudio de cohortes

d. Estudio descriptivo

e. Estudio de intervención comunitaria o cuasiexperimental

Respuesta correcta: a. Estudio de caso control

Explicación: Los estudios ecológicos, de caso control y de cohortes pueden servir para determinar relaciones de causalidad (son estudios analíticos) entre un factor de riesgo y una enfermedad. Además, el de cohortes es de mejor calidad, seguido por el de caso control y finalmente el ecológico que solo sirve como un estudio exploratorio, de baja calidad de información. Sin embargo, por ser una enfermedad muy infrecuente, el estudio de cohortes deja de ser útil y el de caso-control pasa a ser el de elección (también es de elección si es una enfermedad que demora muchos años en aparecer o si hay restricciones de presupuesto).

Fuente: Salud pública, cuestionario 2.3, P7

8. Se agregan antioxidantes a la dieta una población, observándose la variación en las tasas de infarto ¿A qué tipo de estudio corresponde?

a. Descriptivo

b. De prevalencia

c. De casos y controles

d. De cohorte

e. Experimental

Respuesta correcta: e. Experimental

Explicación: Se está realizando una intervención (se controla una variable), por lo que es experimental. Con la información que se entrega, no queda claro si es de intervención comunitaria o si es un ensayo de campo o si es un estudio clínico, pero sí se sabe que es experimental. Los demás son observacionales.

Fuente: Salud pública, cuestionario 2.3, P17

Medidas de frecuencia (7)

9. ¿Cuál de los siguientes parámetros es más adecuado para determinar la contagiosidad de una enfermedad?

a. Tasa de virulencia
b. Tasa de mortalidad
c. Tasa de letalidad
d. Tasa de prevalencia
e. Tasa de ataque

Respuesta correcta: e. Tasa de ataque

Explicación: Es una pregunta difícil, pero la tasa de ataque es una tasa de incidencia de corta duración, que evalúa la contagiosidad de las enfermedades infecciosas.

Fuente: Salud pública, cuestionario 2.1, P2

10. En Chile se realiza una radiografía AP de pelvis a todos los lactantes de 3 meses. ¿Cuál es el mejor indicador para determinar el éxito de la utilización de dicha radiografía para la prevención de la displasia de cadera?

a. Tasa de incidencia
b. Tasa de prevalencia
c. Tasa de hospitalizaciones
d. Tasa de mortalidad
e. Tasa de cobertura

Respuesta correcta: b. Tasa de prevalencia

Explicación: Es una pregunta difícil, ya que la tasa de cobertura sí es útil para determinar si se está realizando o no la medida (la radiografía). Sin embargo, la prevención en sí se evalúa con la caída de las tasas de incidencia y de prevalencia. La tasa de incidencia solo baja en las medidas de prevención primaria (no es el el caso, ya que la radiografía de cadera es una prueba de screening, es decir, una medidad de prevención secundaria). La tasa de prevalencia disminuye en las medidas de prevención primaria, secundaria y terciaria (excepto en las patologías incurables, en que aumenta la prevalencia, ya que menos pacientes fallecen).

Fuente: Salud pública, cuestionario 2.1, P4

11. ¿Cuál es el mejor indicador para ver si la vacunación contra el papiloma humano es una medida efectiva?

a. Disminución de la tasa de incidencia
b. Disminución de la tasa de prevalencia
c. Disminución de la tasa de letalidad
d. Disminución de la tasa de mortalidad
e. Aumento de la supervivencia de la enfermedad

Respuesta correcta: a. Disminución de la tasa de incidencia

Explicación: La vacunación es una medida de prevención primaria, por lo que disminuye la tasa de incidencia y solo secundariamente reduce la prevalencia. Las medidas de prevención secundaria solo disminuyen la prevalencia. De todos modos, sigue siendo una pregunta difícil, ya que el objetivo final de la vacunación contra el VPH es la disminución de la mortalidad por cáncer de cuello uterino.

Fuente: Salud pública, cuestionario 2.1, P16

12. ¿A qué indicador corresponde la siguiente afirmación "De 1.000 pacientes embarazadas con bacteriuria asintomática y sin tratamiento, 300 desarrollan pielonefritis durante su embarazo"?

a. Letalidad
b. Prevalencia
c. Riesgo relativo
d. Asociación
e. Incidencia

Respuesta correcta: e. Incidencia

Explicación: La incidencia son los casos nuevos sobre el total: en este caso es una incidencia de 30%. En estricto rigor, es "incidencia acumulada", sin embargo, el término "incidencia" es equívoco y se usa con muchas acepciones distintas.

Fuente: Salud pública, cuestionario 2.1, P18

13. ¿Cuál de los siguientes indicadores demostraría la efectividad de un programa de realización de mamografías periódicas en una población?

a. Disminución de la incidencia de cáncer de mama
b. Disminución de la prevalencia de los factores de riesgo del cáncer de mama
c. Disminución de la tasa de mortalidad por cáncer de mama
d. Aumento en el porcentaje de mujeres que se realizan mamografías
e. Aumento en el número de cánceres de mama diagnosticados con la mamografía

Respuesta correcta: c. Disminución de la tasa de mortalidad por cáncer de mama

Explicación: Por ser una medida de prevención secundaria, no afecta la incidencia (la primaria sí). La prevalencia no es un buen indicador, ya que salen de ella, tanto quienes se mejoran, como quienes se mueren. La reducción de la mortalidad es el objetivo mismo de los programas de screening de todos los cánceres. La D y E son indicadores que algo de utilidad tendrán, pero no muestran efectividad (capacidad de generar resultados favorables en condiciones reales), sino solo dan una idea de la correcta implementación del programa.

Fuente: Salud pública, cuestionario 2.2, P16

14. Se pretende planificar la compra de antibióticos endovenosos para el sistema público. ¿Qué indicador es más adecuado para ello?

a. Tasa de mortalidad
b. Tasa de prevalencia
c. Tasa de ataque
d. Tasa de letalidad
e. Tasa de incidencia

Respuesta correcta: e. Tasa de incidencia

Explicación: Los antibióticos a comprar dependerán del número de casos de enfermedades infecciosas que ocurran durante un periodo de tiempo, es decir, de la incidencia. En cambio, en el caso de una enfermedad crónica, la cantidad de medicamentos a comprar, dependerán de la tasa de prevalencia. La tasa de mortalidad solo muestra el número de muertes por dicha enfermedad, en el total de la población. La tasa de letalidad da cuenta de la severidad de la enfermedad y el riesgo de morir, si es que se enferma. La tasa de ataque muestra la contagiosidad de la enfermedad (corresponde a la tasa de incidencia, en un periodo breve de tiempo, en los sujetos expuestos).

Fuente: Salud pública, cuestionario 2.3, P11

15. Recientemente se incorporó la vacuna contra la hepatitis A en el plan nacional de inmunizaciones, a los 18 meses de edad. ¿Qué indicador es más adecuado para evaluar el éxito de esta intervención?

a. Tasa de efectos adversos
b. Tasa de prevalencia
c. Tasa de cobertura
d. Tasa de letalidad
e. Tasa de incidencia

Respuesta correcta: e. Tasa de incidencia

Explicación: La vacunación es una medida de prevención primaria, por lo que evita el desarrollo de una enfermedad, antes de que exista. Por tanto, disminuye la incidencia y su éxito se mide en base a la caída de la incidencia. Es cierto que baja también la prevalencia, pero no es un buen indicador tanto por ser una medida de prevención primaria, como porque la hepatitis es una enfermedad infecciosa aguda, en la que la prevalencia no da mucha información. Las medidas de prevención secundaria y terciaria solo disminuyen la prevalencia y no afectan la incidencia, ya que actúan cuando la enfermedad ya está presente. La tasa de cobertura sí es importante, pero para determinar la correcta implementación de la medida y no su eficacia o éxito.

Fuente: Salud pública, cuestionario 2.3, P12

Medidas de asociación e interpretación de resultados (8)

16. Se busca la asociación entre distintos parámetros con el cáncer de tiroides, en un estudio de caso - control, con el Odds Ratio (OR), más un intervalo de confianza (IC) al 95%. ¿Qué factor es más importante en esta asociación?

a. Antecedentes familiares: OR: 1,88 ; IC [0,56 - 4,01]
b. Edad: OR: 2,6 ; IC [0,95 - 3,17]
c. Tiroiditis de Hashimoto: OR: 4,6 ; IC [0,7 - 6,2]
d. Exposición a radiación: OR: 1,12 ; IC [1,01 - 1,33]
e. Sexo femenino: OR: 2,56 ; IC [2,33 - 2,87]

Respuesta correcta: e. Sexo femenino: OR: 2,56 ; IC [2,33 - 2,87]

Explicación: Las opciones A, B y C no son significativas, ya que el OR pasa por el número 1. Las opciones D y E sí son significativas, pero la E es la correcta, ya que tiene un OR mayor.

Fuente: Salud pública, cuestionario 2.1, P6

17. Se realiza un estudio de casos y controles que busca establecer la asociación entre el uso de anticonceptivos orales y cáncer de mama. Luego de analizar los datos se obtiene que el Riesgo Relativo de

1,5 con intervalo de confianza al 95% con valores entre 1,2 y 2,0. Con estos resultados se puede afirmar que:

a. Existe una relación positiva entre el uso de anticonceptivos orales y el desarrollo de cáncer
b. Existe una relación positiva entre el uso de anticonceptivos orales y el desarrollo de cáncer, pero que no es estadísticamete significativa
c. Existe una asociación entre el uso de anticonceptivos orales y el desarrollo de cáncer, pero este resultado no es extrapolable a otras poblaciones
d. Las personas que tienen cáncer consumieron un 50% más de anticonceptivos orales
e. El 95% de las personas que usan anticonceptivos orales, tienen 1,5 veces más riesgo de desarrollar cáncer.

Respuesta correcta: a. Existe una relación positiva entre el uso de anticonceptivos orales y el desarrollo de cáncer

Explicación: Tiene un RR mayor a 1, por lo que hay una relación positiva (aumenta el riesgo). Además, en el intervalo de confianza no pasa por el 1, por lo que es estadísticamente significativo.

Fuente: Salud pública, cuestionario 2.1, P10

18. En un estudio de cohortes sobre el tabaco y cáncer de pulmón, luego de 20 años, se determinad que 65 de 2.000 pacientes fumadores enfermaron de cáncer pulmonar, mientras que solo 5 de los 3.200 paciente no fumadores lo hicieron. ¿Qué medida es posible calcular con esta información?

a. Mortalidad
b. Prevalencia en los pacientes fumadores
c. Riesgo relativo
d. Odds ratio
e. Tasa de letalidad

Respuesta correcta: c. Riesgo relativo

Explicación: El RR se calcula como incidencia expuestos / incidencia en no expuestos. Es decir: (65/2.000) / (5/3.200).

Fuente: Salud pública, cuestionario 2.1, P19

19. Un estudio selecciona a un grupo de mujeres embarazadas con alteraciones en el Doppler de arterias uterinas, a las que se les inicia tratamiento con aspirina y se compara con otro grupo de las mismas características, a las que se les inicia L- arginina más aspirina. ¿Qué medida de asociación se debe utilizar en este estudio?

a. Riesgo relativo
b. Riesgo atribuible
c. T de Student
d. Odds ratio
e. Incidencia

Respuesta correcta: a. Riesgo relativo

Explicación: Se trata de un ensayo clínico controlado, por lo que se pueden calcular incidencias y calcular el riesgo relativo (RR), que es la medida de asociación más importante. El RR también se usa en los estudios de cohortes. El odds ratio (OR) se usa en los estudios transversales (de prevalencia) y en los casos

y controles. El riesgo atribuible (RA) es una medida de impacto (no de asociación), que se puede calcular en estudios de cohortes y ensayos clínicos.

Fuente: Salud pública, cuestionario 2.2, P6

20. Se evalúa un nuevo fármaco para el tratamiento de la pancreatitis, determinando el riesgo de muerte, en comparación con el tratamiento habitual. Se obtiene que el nuevo fármaco presente un RR de 1,25 con IC 95% [1,20 – 1,30]. Al respecto se puede afirmar que:

a. El nuevo fármaco aumenta la mortalidad en un 25% aproximadamente
b. Entre el 20% y el 30% de los pacientes que reciben el nuevo fármaco morirán
c. El nuevo fármaco es 1,25% más eficaz para prevenir la muerte
d. Se debe tratar entre 20 y 30 pacientes con el nuevo fármaco, para que uno se beneficie
e. El nuevo fármaco no presenta diferencias significativas con el tratamiento habitual

Respuesta correcta: a. El nuevo fármaco aumenta la mortalidad en un 25% aproximadamente

Explicación: El RR > 1 aumenta el riesgo. Como es 1,25, aumenta el riesgo en 25% (1,25 – 1 = 0,25 = 25%). Como el intervalo de confianza no pasa por el 1, es estadísticamente significativo. Sabemos que no pasa por el 1, porque 1,20 y 1,30 son ambos mayores que 1. Por el contrario, si uno fuera mayor que 1 y el otro menor que 1, no sería significativo (ej. 0,9 – 2,1). La B es falsa porque se refiere a la incidencia de muerte. La D es falsa porque se refiere al NNT (número necesario para tratar).

Fuente: Salud pública, cuestionario 2.2, P10

21. Se realiza un estudio de casos y controles, que muestra que el jugo de pomelo o toronja tiene un Odds Ratio de 4,1 para presentar efectos adversos, relacionados con el uso de anticoagulantes orales, con p = 0,01. Se puede concluir que:

a. El jugo de pomelo aumenta 4,1 veces el riesgo de sufrir efectos adversos
b. El jugo de pomelo aumenta en 1% el riesgo de sufrir efectos adversos
c. El jugo de pomelo aumenta en 4,1% el riesgo de sufrir efectos adversos
d. El 4,1% de los pacientes que toman jugo de pomelo y consumen anticoagulantes, presentan efectos adversos atribuibles directamente al jugo de pomelo
e. El jugo de pomelo podría aumentar el riesgo de sufrir efectos adversos, pero los datos presentados no permiten estar seguros, por no haber diferencias estadísticas significativas

Respuesta correcta: a. El jugo de pomelo aumenta 4,1 veces el riesgo de sufrir efectos adversos

Explicación: Un OR > 1 aumenta el riesgo en el número de vecen del OR mismo. Además, por tener un p < 0,05, las diferencias son estadísticamente significativamente. El riesgo aumentó 4,1 veces, es decir, 310%. La opción D se refiere al riesgo atribuible porcentual. Por si acaso, el jugo de pomelo sí interactúa con muchos fármacos de uso frecuente, por lo que se debe evitar, si se utiliza alguno de estos fármacos.

Fuente: Salud pública, cuestionario 2.2, P15

22. Se evalúa la relación entre la exposición a un determinado fármaco y el desarrollo de una enfermedad, obteniéndose un Odds Ratio (OR) de 0,5, con un intervalo de confianza (IC) al 95% de [0,42 - 0,57]. ¿Cuál de las siguientes aseveraciones es más correcta?

a. Se trata de un factor protector
b. Se trata de un probable factor protector, pero su efecto no es estadísticamente significativo
c. No existe relación entre el fármaco y la enfermedad
d. Se trata de un probable factor de riesgo, pero su efecto no es estadísticamente significativo

e. Se trata de un factor de riesgo.

Respuesta correcta: a. Se trata de un factor protector

Explicación: El OR menor a 1 indica que disminuye el riesgo (disminuye la probabilidad de enfermarse), por lo que sería un factor protector. Además, como el IC al 95% no pasa por el 1, su efecto es estadísticamente significativo. Si pasara por el 1, no sería estadísticamente significativo (ej. [0,12 - 1,07]). Si el OR fuera igual a 1, no existiría relación. Si el OR fuera mayor a 1, sería un factor de riesgo (aumenta la probabilidad de enfermarse). Igualmente, se debería ver el IC para ver si su efecto es significativo: si pasa por el 1 no es significativo.

Fuente: Salud pública, cuestionario 2.3, P14

23. ¿A qué indicador corresponde la siguiente afirmación: "La promiscuidad sexual aumenta 2 veces el riesgo de embarazo ectópico"?

a. Incidencia
b. Riesgo relativo
c. Prevalencia
d. Riesgo atribuible
e. Intervalo de confianza

Respuesta correcta: b. Riesgo relativo

Explicación: El riesgo relativo refleja el número de veces que aumenta el riesgo (o la incidencia) al estar expuesto a un factor de riesgo. La incidencia sería "un 2% de los pacientes con promiscuidad sexual desarrollan un embarazo ectópico". La prevalencia sería "un 2% de los pacientes con promiscuidad sexual tienen embarazo ectópico". El riesgo atribuible sería "la diferencia de incidencias o de riesgo de embarazo ectópico, entre las pacientes con promiscuidad sexual y las pacientes sin promiscuidad sexual es 2%.

Fuente: Salud pública, cuestionario 2.3, P20

Sesgos (5)

24. ¿Qué tipo de sesgo se trata de evitar, al calibrar los instrumentos de medición en un estudio?

a. Sesgo de memoria
b. Sesgo de información
c. Sesgo de confusión
d. Sesgo de selección
e. Sesgo del entrevistador

Respuesta correcta: b. Sesgo de información

Explicación: La calibración disminuye el sesgo de medida, también llamado sesgo de información.

Fuente: Salud pública, cuestionario 2.1, P5

25. Se realiza un estudio en el que se busca la asociación entre el uso de anticonceptivos orales y el desarrollo de hipertensión arterial, el cual concluye que no existe mayor riesgo de desarrollo de hipertensión arterial en pacientes que utilizaban anticonceptivos orales. No obstante, notaron que las pacientes que recibieron anticonceptivos orales hicieron más crisis hipertensivas que aquellas que no lo recibieron. Sin embargo, decidieron no dar a conocer este último hallazgo, dado que no estaba dentro de los objetivos iniciales del estudio. ¿Qué sesgo se encuentra presente en el estudio descrito?

a. Sesgo de selección

b. Sesgo de notificación
c. Sesgo por exclusión
d. Sesgo por vigilancia
e. Sesgo por el evaluador

Respuesta correcta: b. Sesgo de notificación

Explicación: El sesgo de notificación es aquel en que no se notifican ciertos hallazgos, que podrían ser de interés científico. El sesgo de exclusión es aquel en que se dejan fuera algunos sujetos, que podrían ser representativos de la población.

Fuente: Salud pública, cuestionario 2.1, P13

26. Un estudio compara la prevalencia de patología psiquiátrica en trabajadores de distintas empresas, con jornadas laborales de diferente duración, aplicando una encuesta de 40 preguntas a los trabajadores. Se encontró correlación entre dicho tipo de patologías y jornadas mayores a 40 horas semanales. Sin embargo, las preguntas elegidas no eran bien comprendidas por los trabajadores, dado que usaban un lenguaje muy técnico y no se habían estandarizado. ¿A qué tipo de error corresponde esto?

a. Error alfa
b. Sesgo de notificación
c. Sesgo de información
d. Sesgo de confusión
e. Sesgo de selección

Respuesta correcta: c. Sesgo de información

Explicación: Es un clásico sesgo de información o medida, que incluye la mala estandarización de cuestionarios, la falta de validación de las pruebas diagnósticas, la inadecuada calibración de los instrumentos de medición (se solucionan con adecuada calibración, estandarización, etc.), así como los problemas del evaluador y del paciente que conocen su tratamiento (se solucionan con doble ciego). El error alfa es el error causado por el azar, en el que se rechaza la hipótesis nula, siendo cierta (se dice que sí hay diferencias, cuando no las hay. El sesgo de notificación es aquel que no comunica una información relevante clínicamente, por no estar en el plan del estudio (ej. que no se hubiese notificado que había muchos infartos en un grupo). Los demás sesgos deben revisarlos en el resumen.

Fuente: Salud pública, cuestionario 2.2, P19

27. ¿Qué sesgo se trata de evitar al realizar un ensayo clínico con doble ciego, es decir, donde el sujeto de estudio no sabe qué tratamiento está recibiendo y el evaluador tampoco?

a. Sesgo de información
b. Sesgo de confusión
c. Sesgo del entrevistador
d. Sesgo de selección
e. Sesgo memoria

Respuesta correcta: a. Sesgo de información

Explicación: El doble ciego se utiliza para evitar sesgo de información o medida. También sirve calibrar los instrumentos de medición.

Fuente: Salud pública, cuestionario 2.3, P13

28. Se realiza un estudio que demuestra que los niños de las familias de altos ingresos tienen una prevalencia de trastorno por déficit atencional 3 veces mayor que la de los niños de las familias de menores ingresos. Sin embargo, se observa que los niños de familias de mayores ingresos tienen un número mucho mayor de atenciones de tipo psicológica y psicopedagógica, en las que podrían ser diagnosticados. ¿Qué tipo de sesgo es posible identificar?

a. Sesgo de información
b. Sesgo de notificación
c. Sesgo de confusión
d. Sesgo de selección
e. Sesgo de vigilancia

Respuesta correcta: e. Sesgo de vigilancia

Explicación: Es un ejemplo claro de sesgo de vigilancia: se tiene una mayor frecuencia de enfermedad, simplemente porque se vigila más y hay más instancias en las que se puede hacer el diagnóstico. Ver el resumen de salud público, en el tema "sesgos".

Fuente: Salud pública, cuestionario 2.3, P18

Criterios de causalidad (3)

29. Según los criterios de causalidad de Hills Bradtford, ¿cuál es requisito para establecer una asociación causal?

a. Fuerza de asociación
b. Plausibilidad biológica
c. Respuesta dosis dependiente
d. Secuencia temporal
e. Asociación estadística

Respuesta correcta: d. Secuencia temporal

Explicación: Según algunos autores, el único parámetro que necesariamente debe estar es la secuencia temporal, en la que la causa debe estar antes que el efecto.

Fuente: Salud pública, cuestionario 2.1, P3

30. La presencia del Helicobacter pylori produce inflamación crónica de la mucosa gástrica, acelerando la proliferación celular y aumentando la frecuencia de aparición de mutaciones de las células epiteliales. Esto se utiliza como uno de los argumentos para afirmar la relación causal entre esta bacteria y dicha patología. ¿A qué criterio de causalidad de Bradtford Hills corresponde?

a. Asociación
b. Relación dosis efecto
c. Plausibilidad biológica
d. Cesación de la exposición
e. Congruencia con el conocimiento científico existente

Respuesta correcta: c. Plausibilidad biológica

Explicación: La plausibilidad biológica es una explicación científica racional de la relación causal.

Fuente: Salud pública, cuestionario 2.1, P9

31. Se analizan algunos estudios en pacientes con diagnóstico de cáncer cuello uterino, que previamente habían realizado una colposcopía, con diagnóstico de neoplasia intraepitelial (NIE). Se observó que entre el diagnóstico de NIE y de cáncer transcurrió, en promedio, un tiempo de 5 años en las NIE-2 y de 3 años en las NIE 3. ¿A qué criterios de causalidad de Hills corresponde esto?

a. Replicabilidad
b. Congruencia
c. Plausibilidad biológica
d. Secuencia temporal
e. Asociación

Respuesta correcta: d. Secuencia temporal

Explicación: La secuencia temporal es el único criterio sine qua non (requisito obligatorio) y consiste en que la causa debe preceder al efecto. La replicabilidad se refiere a la posibilidad de repetir el estudio. La congruencia se refiere a tener resultados similares entre los distintos estudios. La plausibilidad biológica se refiere a contar con una explicación racional y acorde con los conocimientos científicos. La fuerza de asociación se determina con el riesgo relativo (o el odds ratio).

Fuente: Salud pública, cuestionario 2.3, P9

Tamizaje y pruebas diagnósticas (4)

32. Un paciente consulta por baja de peso y tos de 1 mes de evolución. Se realiza un Elisa VIH, que está positivo y un Western Blot, que también resultó positivo. ¿Qué característica de este último examen permite confirmar el diagnóstico de VIH?

a. Alta especificidad
b. Alta sensibilidad
c. Elevado valor predictivo negativo
d. Elevado valor predictivo positivo
e. Bajo likelihood ratio (índice de probabilidad)

Respuesta correcta: d. Elevado valor predictivo positivo

Explicación: Tanto la alta especificidad, como el alto valor predictivo positivo son útiles para confirmar. Sin embargo, como se dice que ya está positivo, se está preguntando el VPP (probabilidad de que esté enfermo, cuando el resultado esté positivo). En cambio, la alta sensibilidad y el alto valor predictivo negativo son útiles para descartar una enfermedad. Si ya está negativo, se estaría preguntando el VPN.

Fuente: Salud pública, cuestionario 2.2, P2

33. ¿En cuál de las siguientes enfermedades sería más adecuado contar con un programa de tamizaje?

a. Enfermedad de Alzheimer
b. Infección por virus respiratorio sincicial
c. Infección por VIH
d. Cáncer basocelular de piel
e. Fracturas de huesos largos

Respuesta correcta: c. Infección por VIH

Explicación: Las pruebas de tamizajes son útiles para enfermedades que cumplan con todo lo siguiente: 1. Sean frecuentes (de lo contrario se gastaría demasiado dinero en las pruebas de screening), 2. Tengan un

tratamiento eficaz (si no, no sirve de nada diagnosticarlas antes; no necesariamente debe ser un tratamiento curativo), 3. Sean graves (si son leves, da igual diagnosticarlas tardíamente), 4. Tengan un periodo de latencia, asintomático, en el que se pueda realizar la prueba de tamizaje y en el que se aplicar realizar el tratamiento efectivo (si tiene síntomas desde el inicio, basta con el diagnóstico clínico). VIH calza con todo esto. El Alzheimer no tiene tratamiento eficaz. El VRS tiene un periodo de incubación muy corto y da síntomas de inmediato. El cáncer basocelular se puede tratar tardíamente y da síntomas desde el inicio. Las fracturas tienen síntomas desde que se producen.

Fuente: Salud pública, cuestionario 2.2, P3

34. ¿Cuál de las siguientes opciones justifica la realización de pruebas tamizaje para una enfermedad?

a. Muy baja frecuencia
b. Ausencia de un tratamiento eficaz disponible
c. Presencia de síntomas desde los primeros días de la enfermedad
d. Alta contagiosidad y letalidad
e. Alto riesgo de progresión a complicaciones graves o irreversibles

Respuesta correcta: e. Alto riesgo de progresión a complicaciones graves o irreversibles

Explicación: Las pruebas de screening se utilizan para hacer un diagnóstico precoz, en un paciente asintomático, de modo de realizar un tratamiento oportuno, antes de que aparezcan complicaciones más graves. Así, el tamizaje tiene sentido cuando es una patología con cierta frecuencia (si es muy infrecuente, sería un costo alto, sin mayor utilidad), debe tener un tratamiento eficaz (ya que de lo contrario, no importa hacer el diagnóstico precoz, ya que no se puede tratar), no debe tener síntomas al inicio (ya que si los tiene, no es necesario hacer el screening y basta con estudiar a los pacientes sintomáticos), en enfermedades de larga duración (por eso en las enfermedades infecciosas, de alta contagiosidad o virulencia, se prefiere utilizar políticas de vigilancia activa y control del caso y sus contactos, en lugar de pruebas de screening, que se usa para enfermedades más crónicas) y finalmente debe tratarse de una enfermedad grave, con riesgo de progresar, complicarse o producir la muerte (de lo contrario, si fuera una enfermedad banal, bastaría con tratar a los enfermos, sin esforzarse en diagnosticar la enfermedad antes.

Fuente: Salud pública, cuestionario 2.3, P4

35. En los consultorios y otros centros de atención primaria ¿Para qué se realiza la toma de presión arterial a todos los pacientes que consultan, incluso por síntomas que no deberían estar relacionados con las cifras de tensión arterial?

a. Para realizar la vigilancia sanitaria de una las patologías más importante de la población
b. Para realizar tamizaje a al azar, en la población
c. Para detectar a los pacientes de alto riesgo cardiovascular
d. Para hacer diagnóstico precoz e indicar tratamiento oportuno
e. Para evaluar el impacto del tratamiento antihipertensivo

Respuesta correcta: d. Para hacer diagnóstico precoz e indicar tratamiento oportuno

Explicación: Es una pregunta rara. La toma de presión arterial es parte del examen físico, por lo que sirve fundamentalmente para la evaluación clínica del paciente. Sin embargo, se utiliza además como un sistema de screening de hipertensión arterial, que permite un diagnóstico precoz, para un tratamiento oportuno (prevención secundaria). La vigilancia sanitaria de la hipertensión se realiza con estudios poblacionales, como la Encuesta Nacional de Salud. El tamizaje no se hace al azar en la población, sino en todo paciente que consulta. No hay datos en el enunciado que orienten a que se evalúa el tratamiento antihipertensivo (se haría con un ensayo clínico). Finalmente sí ayuda a detectar a los pacientes de alto

riesgo, pero ello implica más exámenes y evaluación de más factores de riesgo (glicemia, perfil lipídico, hábito tabáquico, antecedentes familiares, etc), por lo que nos inclinamos a desechar esta opción.

Fuente: Salud pública, cuestionario 2.3, P5

Niveles de prevención (5)

36. ¿A qué tipo de medida corresponde la administración intramuscular de vitamina K que se hace a todos los recién nacidos en Chile?

a. Promoción de la salud
b. Protección de la salud
c. Prevención primaria
d. Prevención secundaria
e. Prevención terciaria

Respuesta correcta: c. Prevención primaria

Explicación: Es una medida que previene la coagulopatía del recién nacido, por lo que es prevención primaria. Otra forma de verlo es que aún no hay síntomas ni enfermedad, al momento de administrarla, por lo que es prevención primaria.

Fuente: Salud pública, cuestionario 2.1, P8

37. ¿A que tipo de medida corresponde la educación sobre sexualidad responsable y prevención de enfermedades de transmisión sexual en la adolescencia?

a. Promoción de salud
b. Protección específica
c. Erradicación de la enfermedad
d. Diagnóstico oportuno
e. Tratamiento precoz

Respuesta correcta: a. Promoción de salud

Explicación: Es una medida de prevención primaria, en específico, promoción de la salud, ya que busca educar y generar hábitos de vida saludable.

Fuente: Salud pública, cuestionario 2.1, P14

38. Una paciente consulta por porque toda su familia ha tenido cálculos biliares, por lo que le preocupa que ella también pueda sufrirlos. Por eso se le realiza una ecografía abdominal, la que confirma la presencia de dichos cálculos. Esto corresponde a una medida de:

a. Prevención primaria
b. Prevención secundaria
c. Prevención terciaria
d. Prevención cuaternaria
e. Prevención específica

Respuesta correcta: b. Prevención secundaria

Explicación: La redacción de la pregunta la hace difícil, pero se está haciendo un diagnóstico oportuno, para un tratamiento precoz, por lo que se trata de prevención secundaria. Visto de otra forma, ya tiene le enfermedad, pero no síntomas, por lo que es secundaria. La primaria no tiene ni síntomas ni enfermedad y lo que se busca es prevenir el desarrollo de la enfermedad. La terciaria ya tiene síntomas y enfermedad,

por lo que se busca curar, rehabilitar y evitar las complicaciones, secuelas y recurrencias. La cuaternaria es la que tiene síntomas, pero no enfermedad orgánica (ej. trastorno somatomorfo), por lo que se busca es identificar la patología mental y diferenciarla de la orgánica. La prevención específica es un tipo de prevención primaria, que previene una enfermedad en específico (ej. vacunas).

Fuente: Salud pública, cuestionario 2.2, P13

39. ¿A qué tipo de intervención corresponde el trabajo de la fundación Teletón, que se encarga de apoyar y rehabilitar a niños y adultos con discapacidad?

a. Protección de salud
b. Promoción de salud
c. Prevención primaria
d. Prevención secundaria
e. Prevención terciaria

Respuesta correcta: e. Prevención terciaria

Explicación: La rehabilitación es prevención terciaria, ya que la enfermedad y los síntomas están presentes. La prevención secundaria tiene enfermedad presente, pero asintomática. La primaria aún no tiene la enfermedad, ni síntomas (promoción y protección de salud son medidas de prevención primaria).

Fuente: Salud pública, cuestionario 2.3, P15

40. ¿A qué tipo de medida corresponde el uso de anticonceptivos combinados orales, para evitar los embarazos no deseados?

a. Prevención primaria
b. Prevención secundaria
c. Prevención terciaria
d. Prevención cuaternaria
e. Prevención gestacional

Respuesta correcta: a. Prevención primaria

Explicación: Es una pregunta algo capciosa, porque el embarazo no es una enfermedad (tal vez el embarazo no deseado podría considerarse un problema de salud). Sin embargo, se evita la situación antes de que exista (disminuye la incidencia de embarazo), por lo que se trataría de una medida de prevención primaria.

Fuente: Salud pública, cuestionario 2.3, P19

Organización y financiamiento del sistema de salud chileno (11)

41. Qué institución, dependiente directamente del Ministerio de Salud, debe velar por el funcionamiento adecuado, eficiente y coordinado de los distintos prestadores de la salud pública:

a. La Superintendencia de Salud
b. La Secretaría Regional Ministerial de Salud
c. La Dirección del Servicio de Salud
d. La Subsecretaría de Redes Asistenciales
e. La Dirección de Salud Comunal

Respuesta correcta: d. La Subsecretaría de Redes Asistenciales

Explicación: El Minsal tiene 2 subsecretarías, que dependen directamente de él: La subsecretaría de Salud Pública (encargada de las políticas de salud pública) y la subsecretaría de Redes Asistenciales (encargadas de los prestadores públicos y privados de salud, es decir, de la red asistencial).

Fuente: Salud pública, cuestionario 2.1, P1

42. ¿Cuál de las siguiente actividades o medidas, está relacionado con el principio de oportunidad de las garantías explícitas de salud (GES)?:

a. Autorización sanitaria de prestadores y laboratorios
b. Certificación por parte de la superintendencia de los prestadores de salud
c. Vigilancia del cumplimiento de plazos
d. Convenios entre ISAPRES y prestadores de salud
e. Afiliados a Fonasa e Isapres tienen oportunidad de acceder a prestaciones GES

Respuesta correcta: c. Vigilancia del cumplimiento de plazos

Explicación: La oportunidad se refiere a que se reciba el tratamiento en un tiempo oportuno: para ello están los plazos AUGE. Autorización y certificación: principio de calidad. Convenios con privados y Fonasa: principio de acceso universal.

Fuente: Salud pública, cuestionario 2.1, P11

43. Un grupo de cirujanos deciden construir una clínica, con pabellones de cirugía menor y cirugía mayor. ¿Qué institución les debe dar la autorización para poder funcionar?

a. Superintendencia de salud
b. Secretaría regional ministerial
c. Corporaciones municipales de salud
d. Dirección del servicio de salud
e. Superintendencia de seguridad social

Respuesta correcta: b. Secretaría regional ministerial

Explicación: Es una pregunta difícil, ya que la Seremi les dará la autorización sanitaria para funcionar (es lo que se pregunta), pero la Superintendencia de Salud les dará la certificación para poder ser prestadores Fonasa o prestadores AUGE, los inscribirá en el Registro de Prestadores Institucionales de Salud y vigilará su calidad.

Fuente: Salud pública, cuestionario 2.1, P15

44. Paciente de 45 años, trabajador de la construcción, sufre un infarto mientras se encontraba trabajando. ¿Quién cubre los gastos médicos de este paciente?

a. El empleador
b. 50% por parte de FONASA y 50% por parte del trabajador
c. La institución de salud previsional o Fonasa, según el caso
d. La mutual de seguridad
e. El Estado

Respuesta correcta: c. La institución de salud previsional o Fonasa, según el caso

Explicación: Aunque haya sido durante el trabajo, es una enfermedad común, por lo que debe ser cubierta por su previsión de salud: Fonasa o Isapre.

Fuente: Salud pública, cuestionario 2.1, P17

45. Se decide construir un nuevo hospital, que atenderá a todos los pacientes de una determinada comuna. El hospital contará con un servicio de pediatría y urgencia pediátrica. Además de las estadísticas nacionales de salud, ¿qué indicador es más adecuado para determinar la cantidad de personas que se deben contratar para este servicio?

a. El número de niños de la comuna
b. La tasa de fecundidad en la población de la comuna
c. Los recién nacidos de la comuna
d. La mortalidad infantil histórica en esa comuna
e. La tasa de fertilidad de la población

Respuesta correcta: a. El número de niños de la comuna

Explicación: Es una pregunta rara, pero muy parecida a una del Eunacom. Por regla general, lo más útil para determinar la cantidad de recursos humanos a contratar es conocer la demanda histórica de dichos recursos. Sin embargo, por ser un hospital nuevo, no se cuenta con esa información y tendrá que proyectarse la demanda, en base a la población beneficiaria (los niños de la comuna) y las estadísticas nacionales (tasa de consultas según población pediátrica). La tasa de fecundidad da cuenta de la relación entre los recién nacidos y las mujeres en edad fértil. La tasa de fertilidad da una información similar, pero indicando el número de hijos promedio que tendrían las mujeres durante su vida. Los recién nacidos sí podrían dar una información útil, pero importa más el total de niños en este caso. La mortalidad infantil no tiene mayor relevancia, ya que depende de los determinantes de salud, más que del servicio de pediatría y, además, también consultarán niños sanos y niños con patologías no letales.

Fuente: Salud pública, cuestionario 2.2, P8

46. La principal característica del diagnóstico participativo de salud es:

a. La acción conjunta y simultánea de distintos especialistas de la medicina, como internistas, psiquiatras y cirujanos
b. La participación de distintos organismos públicos, como el Ministerio de Salud, en conjunto con el de Salud, de Vivienda y Urbanismo y de Desarrollo Social
c. La participación de múltiples profesionales de la salud, como médicos, enfermeras, dentistas, kinesiólogos y psicólogos
d. La utilización de programas con enfoque biopsicosocial, que no se limitan al manejo de las patologías orgánicas, sino también las enfermedades mentales y los problemas sociales
e. La colaboración activa de los miembros de la comunidad y las organizaciones civiles en la determinación y solución de sus problemas de salud

Respuesta correcta: e. La colaboración activa de los miembros de la comunidad y las organizaciones civiles en la determinación y solución de sus problemas de salud

Explicación: El diagnóstico participativo de salud es aquél en el que las personas de la comunidad, en la que se está haciendo el diagnóstico, ayudan a identificar sus problemas de salud y colaboran con el diseño de los programas de intervención. Suelen incluir a las organizaciones civiles, como los colegios, juntas de vecinos, organizaciones sin fines de lucro, etc.

Fuente: Salud pública, cuestionario 2.2, P9

47. Las instituciones previsionales de salud obtienen su financiamiento principalmente de:

a. La prima mensual que pagan los trabajadores
b. El aporte estatal

c. El aporte de las municipalidades
d. El copago que realizan los pacientes que reciben una prestación de salud
e. El aporte mensual que pagan los empleadores

Respuesta correcta: a. La prima mensual que pagan los trabajadores

Explicación: Las Isapres se financian con el 7% de los trabajadores (más un porcentaje opcional, según el plan de salud que se contrate). Reciben un mínimo aporte estatal, relacionado con las patologías AUGE. Fonasa se financia del aporte estatal directo, luego por el 7% de los trabajadores. La salud de atención primaria (consultorios) se financian con el aporte per cápita y luego por el aporte municipal directo (ambos administrados por la municipalidad). Tanto los pacientes Isapre, como los pacientes Fonasa en la modalidad de libre elección copagan, cuando se atienden, por lo que ellos ayudan a financiar su propia atención de salud. Los pacientes Fonasa no copagan en la modalidad de atención institucional. Ese dinero no va a manos del seguro (Fonasa o Isapre), sino del prestador (clínica, hospital, médico, etc.). Las mutuales (salud laboral) se financian con el aporte del empleador (0,95%, aunque puede variar según el año y la el riesgo de la actividad laboral).

Fuente: Salud pública, cuestionario 2.2, P12

48. Para poder funcionar como un prestador institucional AUGE, las instituciones privadas de salud deben: 1. Contar con la autorización sanitaria vigente (expedida por la Seremi de Salud), 2. Haber ejecutado y concluido el proceso de autoevaluación en los 12 meses anteriores a la solicitud de acreditación (completar el informe de autoevaluación y las fichas técnicas), 3. Cumplir con los estándares definidos por el Ministerio de Salud y 4. Presentar solicitud de acreditación ante la Intendencia de Prestadores de la Superintendencia de Salud. Esto corresponde al principio de:

a. Acceso
b. Oportunidad
c. Calidad
d. Protección financiera
e. Burocracia

Respuesta correcta: c. Calidad

Explicación: Los 4 requisitos mencionados son los necesarios para obtener la certificación de la Superintendencia de Salud. Esta certificación busca asegurar la calidad. Los 4 principios del AUGE son: 1. Acceso: Derecho por Ley de la prestación de Salud. 2. Oportunidad: Tiempos máximos de espera para el otorgamiento de las prestaciones. 3. Protección financiera: La persona beneficiaria cancelará un porcentaje de la cobertura y el Estado, a través del aporte de los contribuyentes, financiará el resto. 4. Calidad: Otorgamiento de las prestaciones por un prestador acreditado o certificado.

Fuente: Salud pública, cuestionario 2.2, P17

49. Actualmente los centros de atención primaria del sistema público de salud (ej. consultorios) están a cargo de:

a. La Dirección de Salud Comunal
b. El Servicio de Salud
c. La Secretaría Regional Ministerial de Salud
d. La Subsecretaría de Redes Asistenciales
e. La Superintendencia de Salud

Respuesta correcta: a. La Dirección de Salud Comunal

Explicación: La atención primaria está a cargo de la Municipalidad, que es el organismo público, encargado de cada comuna. A la cabeza está el alcalde, quien nombra al Director de Salud Comunal, encargado de la salud de la comuna. La red de atención primaria incluye: Consultorios, SAPU (Servicio de Atención Primaria de Urgencia), SAR (Servicio de Urgencia de Alta Resolución), PSR (Postas de Salud Rural) y SUR (Servicio de Salud Rural).

Fuente: Salud pública, cuestionario 2.2, P18

50. ¿Qué autoridad está a la cabeza de los hospitales públicos de una determinada zona geográfica y se encarga de supervisar su gestión?

a. El Subsecretario de Redes Asistenciales
b. El Director del Servicio de Salud
c. El Superintendente de Salud
d. El Seremi de Salud
e. El Director de Salud Comunal

Respuesta correcta: b. El Director del Servicio de Salud

Explicación: La salud secundaria y terciaria (Hospitales y Servicios de Urgencia de alta complejidad) están a cargo de los respectivos Servicios de Salud, que tienen como autoridad máxima al Director del Servicio de Salud. Eso sí, es frecuente que en un Servicio de Salud haya más de un Hospital y cada Hospital cuenta con su propio director, cuyo cargo se llama Director del Hospital y que no es lo mismo que el Director del Servicio de Salud (este último es un cargo más alto). En cambio, los consultorios y la atención primaria (así como el SAPU: servicio de atención primaria de urgencia) están a cargo de la Municipalidad, en manos del Director de Salud Comunal. La Subsecretaría de Redes Asistenciales depende del Minsal y vela por el correcto y coordinado funcionamiento de los centros de salud de todo el país. La Superintendencia de Salud vela por el AUGE y supervigila a Fonasa y las Isapres. Además, certifica la calidad de los prestadores de salud (ej. prestadores Fonasa y prestadores AUGE) y lleva el Registro de Prestadores, que es de público acceso. La Seremi de Salud (Secretaría Regional Ministerial de Salud) representa al Minsal en las regiones y se encarga de todo lo relacionado a la salud pública de la región.

Fuente: Salud pública, cuestionario 2.3, P10

51. ¿Cuál de las siguiente actividades o medidas, está relacionado con el principio de protección financiera de las garantías explícitas de salud (GES)?:

a. Acceso por ley a las pretaciones de salud
b. Completa gratuidad de todas las prestaciones asociadas a patologías AUGE
c. Subsidio estatal para las patologías AUGE, de modo que el afiliado solo pague una parte
d. Multas a Fonasa o las Isapres que no respeten los plazos máximos para entregar una prestación AUGE
e. Irrenunciabilidad de los derechos y coberturas AUGE

Respuesta correcta: c. Subsidio estatal para las patologías AUGE, de modo que el afiliado solo pague una parte

Explicación: Los 4 principios son: 1. Acceso (derecho legal que permite acceder a la prestación), 2. Oportunidad (plazos máximos a respetar), 3. Protección financiera (subsidio estatal) y 4. Calidad (certificación y acreditación de prestadores). Las prestaciones AUGE no son del todo gratuitas para los pacientes Isapres, que deben copagar un 20% de las atenciones, pero, actualmente están 100% cubiertas por Fonasa. En ambos casos, eso sí, igualmente se debe pagar el seguro. Sí se puede renunciar al AUGE (ej. porque la Isapre le ofrece un plan mejor), pero, no es recomendable hacerlo.

Fuente: Salud pública, cuestionario 2.3, P16

Vigilancia epidemiológica y notificación (4)

52. La vigilancia epidemiológica de la influenza y otros virus respiratorios se realiza mediante:

a. Sistema de notificación diaria obligatoria
b. Sistema de cribado en colegios y salas cuna
c. Sistema de notificación inmediata a la Seremi de Salud
d. Sistema de reportes voluntarios desde los centros de salud públicos y privados
e. Sistema de vigilancia por centros centinela

Respuesta correcta: e. Sistema de vigilancia por centros centinela

Explicación: Las enfermedades respiratorias se estudian mediante centros centinelas. También, las diarreas, la varicela y las ITS, distintas al VIH, sífilis y gonorrea, ya que estas 3 se vigilan activamente con sistema de notificación diaria.

Fuente: Salud pública, cuestionario 2.1, P20

53. ¿Qué tipo de enfermedades requieren de una notificación inmediata a la Seremi de Salud?

a. Todas las enfermedades infecciosas, potencialmente letales
b. Las enfermedades agudas de alta gravedad, en especial las infecciosas, pero también aquellas no transmisibles de alta letalidad
c. Las enfermedades infecciosas transmisibles, que requieran de un control rápido ante potenciales brotes, dado su gravedad y baja frecuencia
d. Las enfermedades infecciosas más frecuentes, que afectan a gran parte de la población
e. Las enfermedades transmisibles más graves, que no cuentan con tratamientos curativos, sino solo sintomáticos

Respuesta correcta: c. Las enfermedades infecciosas transmisibles, que requieran de un control rápido ante potenciales brotes, dado su gravedad y baja frecuencia

Explicación: Las enfermedades que se notifican obligatoriamente son aquellas en las que se pretende controlar los brotes o situaciones epidémicas, por lo que deben ser enfermedades contagiosas (vigilancia activa). Además, son enfermedades poco frecuentes en Chile (baja prevalencia) y virulentas (contagiosas y potencialmente letales). No todas las infecciones graves se deben notificar (ej. neumonías, pielonefritis, sepsis abdominal), sino las infrecuentes y contagiosas (no es la A). Las no transmisibles no se notifican de manera inmediata, sino que se manejan con estrategia de vigilancia pasiva (no es la B). Las infecciones más frecuentes, se suelen vigilar mediante centros centinelas, por ejemplo, las infecciones respiratorias y las diarreas (no es la D). Se notifican tanto infecciones graves con tratamiento (ej. meningococcemia), como sin tratamiento específico (ej. sarampión) (no es la E).

Fuente: Salud pública, cuestionario 2.2, P1

54. Cada mes los Servicios de Salud emiten un informe a la Seremi de Salud respectiva, indicándole todas las patologías, que han recibido y resuelto, diferenciándolas por tipo de patología (ej. cardiovasculares, respiratorias, infecciosas, gastrointestinales, quirúrgicas, oncológicas, psiquiátricas, etc.). Así, el Ministerio de Salud cuenta con información, para desarrollar políticas públicas sanitarias. ¿A qué tipo de vigilancia corresponde esto?

a. Vigilancia activa
b. Vigilancia centinela

c. Vigilancia de notificación obligatoria
d. Vigilancia de prevalencia
e. Vigilancia pasiva

Respuesta correcta: e. Vigilancia pasiva

Explicación: La vigilancia pasiva es la básica de los sistemas de salud, en la que se recopilan estadísticas y se hacen programas de salud, pero sin investigar activamente un brote, ni buscar activamente casos. Consiste justamente en lo descrito en esta pregunta. La vigilancia activa, por el contrario, requiere de un sistema de notificación rápida e investigación del brote, para contenerlo y evitar la transmisión. La vigilancia centinela utiliza algunos centros específicos para vigilar ciertas infecciones frecuentes (infecciones respiratorias, diarreas y varicela, en Chile).

Fuente: Salud pública, cuestionario 2.2, P4

55. En un hospital de Concepción consulta un niño de 11 meses, con un cuadro compatible con sarampión, por lo que se decide hospitalizarlo y aislarlo (ailamiento respiratorio), mientras se realiza la confirmación diagnóstica. El médico que lo atendió siguió la normativa vigente y realizó la notificación inmediata a la Secretaría Regional Ministerial de Salud de la región del Biobío. ¿A qué tipo de vigilancia corresponde esto?

a. Vigilancia activa
b. Vigilancia de centros centinela
c. Vigilancia pasiva
d. Vigilancia primaria
e. Vigilancia comunitaria

Respuesta correcta: a. Vigilancia activa

Explicación: En Chile, las enfermedades infecciosas más peligrosas, virulentas, contagiosas o erradicadas (mediante vacunación) son de notificación obligatoria, por lo que hay un sistema de notificación rápida, para estudio inmediato, lo que es característico de la vigilancia activa. Así, la Seremi puede controlar la diseminación de la enfermedad, haciendo un adecuado manejo de los contactos e identificando los demás casos, así como el caso índice. La vigilancia centinela se realiza eligiendo algunos centros de salud (ej. determinado hospital o clínica), que tienen la obligación de estudiar la etiología de ciertas patologías (en Chile, las infecciones respiratorias, diarreas, varicela y las ETS distinas al VIH, sífilis y gonorrea, que se notifican de manera activa y diaria) y notificar los resultados a la Seremi, pero los demás centros de salud no están obligados a hacerlo. La vigilancia pasiva es aquella en la que no se realiza nada de la vigilancia activa, sino que se limita a llevar registro de las patologías, a medida que son diagnosticadas, tras la consulta espontánea de los pacientes y luego se hace un análisis estadístico de los datos obtenidos y se planifica a futuro (pero sin notificación obligatoria, ni actuación por parte de la Seremi para contener el brote). La vigilancia primaria no existe. La vigilancia comunitaria es aquella en la que participa el resto de la población (ej. se educa a los profesores para detectar y notificar casos sospechosos de ciertas enfermedades).

Fuente: Salud pública, cuestionario 2.3, P8

Responsabilidad médica y legislación (4)

56. Un obstetra dejó a un alumno de medicina de 5° año atender un parto sin supervisión, sin embargo, la madre sufrió una hemorragia grave, que terminó con su muerte. ¿A qué tipo de culpa corresponde esto?

a. Dolo

b. Negligencia
c. Impericia
d. Inobservancia
e. Mala práctica

Respuesta correcta: b. Negligencia

Explicación: - El dolo es la intención directa de dañar (no se ve en este caso). - La negligencia es la falta del debido cuidado (por parte del obstetra hay clara negligencia). En este caso, además, hay una gran imprudencia (falta de la precaución, por omitir una diligencia requerida). - La impericia es la falta de conocimiento o falta de habilidad requerida (es lo que tiene el interno en este caso; además, el interno también tiene algo de negligencia e imprudencia, ya que debió haberse negado a atender un parte solo). - La inobservancia es la falta de observación de las normas y reglamentos obligatorios (ej. pasos del protocolo quirúrgico). * La mala práctica es un concepto amplio, que incluye a la negligencia (por lo que sí podría ser correcta), pero que se refiere más a alejarse de la lex artis, es decir, a no dar los cuidados de salud recomendados por la ciencia y la experiencia médica.

Fuente: Salud pública, cuestionario 2.2, P11

57. Un paciente recibe una licencia médica por 11 días, secundaria a una influenza. La Compín la rechazó, argumentando que la influenza debería tener máximo 5 días de licencia, por lo que solo pagará 2. Sin embargo, él decide reclamar, ya que su influenza fue grave y requirió hospitalización, con requerimientos de oxígeno. ¿A qué institución debe dirigirse para reclamar?

a. Fonasa
b. Superintendencia de Salud
c. Superintendencia de Seguridad Social
d. Institución de Salud Previsional
e. Seremi de Salud

Respuesta correcta: c. Superintendencia de Seguridad Social

Explicación: Las licencias médicas rechazadas por la Compín (o por la Contraloría Médica de la Isapre), se pueden reclamar nuevamente en la Compín y la última resolución la tiene la Suseso.

Fuente: Salud pública, cuestionario 2.2, P14

58. Un paciente de 62 años, acude a la ACHS (Asociación Chilena de Seguridad) por un cuadro de lumbago, que inició cuando cargaba un mueble en el trabajo. Al ser atendido, el médico le explica que la patología por la que consulta es de tipo degenerativa y se debe a debilidad de la musculatura de su espalda, por lo que le dará una licencia médica tipo 1 (por enfermedad común) y la ACHS no cubrirá ningún examen. Él quiere reclamar ¿Dónde debe hacerlo?

a. En la Superintendencia de Seguridad Social
b. En la Superintendencia de Salud
c. En la subsecretaría de Redes Asistenciales
d. En la Seremi de Salud
e. En el Compín

Respuesta correcta: a. En la Superintendencia de Seguridad Social

Explicación: Las resoluciones sobre patología laboral, se apelan a la Suseso.

Fuente: Salud pública, cuestionario 2.3, P3

59. Un cirujano, con experiencia en cirugía abierta, decide hacer una colecistectomía laparoscópica, sin supervisión, a pesar de que nunca antes había realizado una laparoscopía. El paciente sufrió complicaciones y tuvo que estar hospitalizado por 2 meses, con alto costo y dolor. ¿A qué tipo de culpa corresponde esto?

a. Negligencia
b. Impericia
c. Impulsividad
d. Mala praxis
e. Descuido

Respuesta correcta: b. Impericia

Explicación: Es una culpa por no tener las habilidades necesarias, lo que se denomina impericia. Puede considerarse, además, un tipo de imprudencia, ya que esta consiste en hacer algo riesgoso, sin el debido cuidado. La negligencia, en cambio, es la culpa por no hacer algo que debía hacerse (culpa por omisión). Descuido es un término genérico, que no se utiliza en la responsabilidad médica. Mala praxis es un término genérico que se refiere a las acciones que generan responsabilidad médica, por lo que, en estricto rigor, sí es un caso de mala praxis, sin embargo, preguntan en específico el tipo de culpa (los tipos son negligencia, imprudencia, impericia y la inobservancia (de leyes, reglamentos o normas en general).

Fuente: Salud pública, cuestionario 2.3, P6

Misceláneos (1)

60. Tratar de aprender Salud Pública es causa de:

a. Jaqueca
b. Frustración
c. Angustia
d. Diarrea
e. Todas las anteriores y mucho más

Respuesta correcta: e. Todas las anteriores y mucho más

Explicación: ¡¡¡Ánimo!!! No importa que aunque les vaya mal en esta prueba, les irá bien en el Eunacom. Eso sí, si les fue mal, hagan el esfuerzo de leer una vez más el resumen, tratando de entender todos los temas que aún no han podido digerir.

Fuente: Salud pública, cuestionario 2.2, P20